

PEDIATRÍA EN RED 3

Prof. Dr. Juan Alberto José Reichenbach

RED PEDIÁTRICA

Dra. Eva Josefina Quintero Fleites

Dra. Cristina Ciriaci

Dra. María Gabriela Bontá

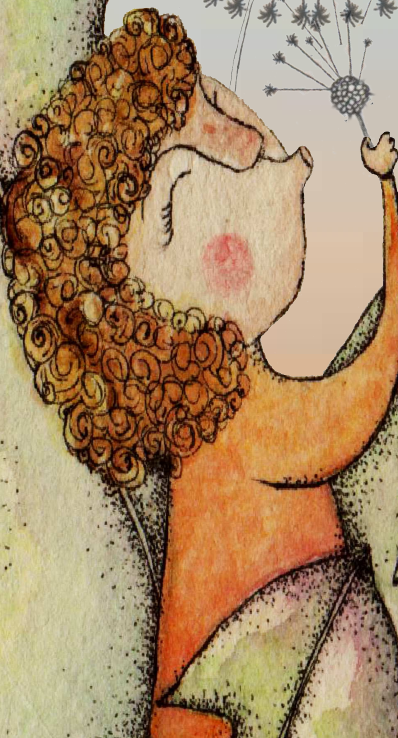
Dra. Marta Vinuesa

Dra. Andrea Sancilio

Dra. Analía Arturi

Dr. Juan Carlos Daniel Morales

Bibl. Verónica Karenina Gallo



ESCUELA
DE GOBIERNO
EN SALUD
**FLOREAL
FERRARA**

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



PEDIATRÍA EN RED 3

Dr. Juan Alberto Reichenbach

RED PEDIÁTRICA

Dra. Eva Josefina Quintero Fleites

Dra. Cristina Ciriaci

Dra. María Gabriela Bontá

Dra. Marta Vinuesa

Dra. Andrea Sancilio

Dra. Analía Arturi

Dr. Juan Carlos Daniel Morales

Bibl. Verónica Karenina Gallo

Reichenbach, Juan Alberto

Pediatría en red 3 / Juan Alberto Reichenbach ;
contribuciones de Eva Josefina Quintero Fleites ...
[et al.] ; prólogo de Mario Rovere, compilado por
Juan Alberto Reichenbach. - 1a ed. - La Plata :
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-47761-1-2

1. Pediatría. 2. Medicina Pediátrica. 3. Medicina
Perinatal. I. Quintero Fleites, Eva Josefina, colab. II.
Rovere, Mario, prol. III. Título.

CDD 618.92

Primera edición, agosto 2020

**Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires**

Calle 4 n° 962, La Plata, Buenos Aires, Argentina

ISBN 978-987-47761-1-2

Hecho el depósito que establece la Ley 11.723

©Juan Reichenbach

© Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Algunos derechos reservados

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative
Commons BY-NC-SA (Atribución-No Comercial-Com-
partir igual) 2.5 Argentina



ISBN 978-987-47761-1-2



AUTORIDADES

Gobernador de la provincia de Buenos Aires

DR. AXEL KICILLOF

Ministro de Salud

DR. DANIEL G. GOLLAN

Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización

LIC. LETICIA CERIANI

Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”

DR. MARIO ROVERE



ESCUELA
DE GOBIERNO
EN SALUD
**FLOREAL
FERRARA**

MINISTERIO
DE SALUD



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

COLABORADORXS

Edición al cuidado de
BIBL. VERÓNICA KARENINA GALLO

Pedagogía
PROF. NORMA DOMÍNGUEZ ORTIZ

Revisión bibliográfica
BIBL. VERÓNICA KARENINA GALLO

Ilustración y diseño de tapa
AMPARO NÚÑEZ

Diseño y edición
CONSTANZA CASTELLS

Asesoría
**ESCUELA DE GOBIERNO EN SALUD FLOREAL
FERRARA**

AUTORES PARTICIPANTES

Por orden de aparición

NÚCLEO A (EXPERTOS)

Prof. Dra. Patricia Ester Climent de Plaza
Prof. Dr. Juan Reichenbach
Dra. Fanny Breitman
Dr. Gustavo H. Sager
Dra. Susana Ortale
Lic. Valeria Andrea Belmonte
Lic. Liliana Mingillo
Dr. Jorge Luis Pepe
Prof. Doctor Adalberto Enrique Palazzi
Dra. Marianela Balanesi
Dra. Claudia Mónica García
Dra. Rut Kiman
Dr. Osvaldo Faustino Azpilicueta
Dra. Sara Fe de la Mella Quintero
Dra. Jacqueline Ponzo
Dr. Walter Pérez
Dr. Jorge L. Cabana
Dra. Stella Maris Gil
Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites
Manuel Acosta
Silvina Alcaza
Fiorella Bianchi
Gonzalo Cabot
Pablo Cáceres
Lorena Caminos
María Fe Carreira Neto
Juan Emilio Ciancio
Loana Cisneros
Salvador Consalvo
Nerina Córscico
Joaquina Da Silva
Daiana Fernández
Micaela Fígaro
Victoria Gómez Roldán
Bernabé Herrera
Macarena Juárez
Kevin Lazarte
Lisandro León
Sofía Porta
Carolina Quinteros
Victoria Ramos
María de la Paz Sedano
Paula Vailati
Dr. Héctor Trebucq
Dr. Carlos Prego
Lic. María Laura Catalano
Dra. Rosana Della Maggiora
Dra. María Esther Gatella
Dr. Gastón Seambelar

Esp. Daniela Pena
Dr. Javier Ignacio Cabana
Dr. Franco Arzamendia
Dra. Alina Guarino
Dra. Ana María Sepúlveda
María Florencia Paiardini
Cintia Anabel Valdebenito
Camila Rosana Vignone
Prof. Dr. Horacio Pracilio
Dr. Fernando Alonso

NÚCLEO B (ESPECIALISTAS)

Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites
Dra. Martina Cisneros
Dra. Guadalupe García Monlezun
Dra. Cintia Esquivel
Dra. Daniela Pereyra Bettoni
Dra. Claudia Chiavazza
Dra. Ianina Massimo
Dra. Sabrina Carme
Dra. Florencia Pruscino
Dra. Melisa Rubio
Dra. Daniela Gutiérrez
Dra. Sabrina Cicero
Dra. Karina Dueñas
Dra. Andrea Sancilio
Dra. Clarisa Menescaldi
Dr. Mauricio Pedersoli Castellani
Dr. Matías Oleastro
Dr. Pablo Gabriel Dei Cas
Dr. Ricardo Gamboa
Dra. Florencia Moreno
Dra. Emilse Andrea Caballero
Dra. María Cecilia Murray
Dra. Camila Ciganek
Dra. Mariana Esteves
Dra. Sabrina Flores
Dra. Marisa Golowczyc
Dra. Adriana León
Dra. Daniela Moya
Dra. Yésica Ramos
Dra. Mercedes Rocha
Dra. Ayelén Rojas Raies
Dra. Nora Patricia Mattarollo
Dr. Juan Carlos Daniel Morales
Dra. Marta Cecilia Vinuesa
Dra. Zulma Cristina Santucci
Dra. Daiana Pérez
Dr. Alejandro Ostrosky
Dra. Elena Maidol

Dra. Fabiana Pestchanker
 Dra. Fernanda Nisimura
 Dr. Diego Piñeyro
 Dra. Marcela Koroluk
 Dra. Natalia Di Pombo
 Dra. Laura Idiart
 Dra. Luz Mariel Suárez Lisperguer
 Dra. Patricia Flores Cruz
 Dr. Hedim Cristian Arias León
 Dra. Karen Rita Simón Abularach
 Dr. Mauricio Nava Ortega
 Dra. Luciana Jimena Petraca

NÚCLEO C **(SITUACIONES CLÍNICAS)**

RED PEDIÁTRICA

Dr. Néstor Nique
 Dra. Leticia Valenciano
 Dra. Verónica Maldonado
 Dra. Estefanía Otero
 Dr. Alejandro Oleiro
 Dra. Carolina Pérez
 Dra. Silvana Iriarte
 Dra. Ayelén Crespo
 Dr. Ángel Gabriel Mascó
 Dra. Julieta Cortesini Leavi
 Dra. Marisa Segovia
 Dra. Laura Cuellar
 Dr. Niko Arredondo Rincón
 Dr. Juan Esteban Amigo
 Dra. Florencia Chica Vergara
 Dra. Fabiola Genilla Rojas
 Dra. M. Carozzo
 Dr. Eduardo Ariel Otero
 Dra. Anabella Coronel
 Dra. Daiana Gallo
 Dra. Jesica Menón
 Dr. Gabriel Teuly
 Dra. Alejandra Capriata
 Dra. Sonia A. Batiuk
 Dra. María Agustina Lagomarsino
 Dra. María de la Paz Ferrín
 Dr. Nicolás Cora
 Dr. Juan Gagnetén
 Dr. Luciano Alva Grimaldi
 Dr. Néstor Pisapia
 Dra. Paula Inés Villalba
 Dra. Mariana Rotolo
 Dra. Natalia Cuevas
 Dra. Isabel Squazzi
 Dra. Cristina Ciriaci
 Dra. Deysi Campos
 Dra. Gabriela Capovilla
 Dra. Antonella Colaneri
 Dra. Gabriela Domijan

Dra. Melina Leppski
 Dra. Natalia Pereyra
 Dr. Leandro Rodríguez
 Dra. Sandra Scarafoni
 Dr. Lucas Ruiz
 Dra. Justina Salvatierra González
 Dra. Viviana Bernedo
 Dra. Antonella Soledad Antonelli Sanz
 Dra. María Candela Cogley
 Dr. Leonel Romero Roldán
 Dra. María Cecilia Eiras
 Dra. María Lorena Cavalieri
 Dra. Silvia Torrez
 Dra. Inés Ivana Barrero Valdez
 Dra. Viviana Lasso
 Od. Juana Bianchi
 Dra. Cintia Barrientos
 Dra. Soledad Corizzo
 Dra. María Florencia González
 Dra. Sofía Riccardi
 Dra. María Cristina Portela
 Dra. Pamela Ecos Fernández
 Dra. Luciana Ourracariet
 Dr. Juan Esteban Arredondo Rincón
 Dra. Mariela Iori
 Dra. Valeria Blois
 Dr. Alejandro Cruz Carozzo
 Dra. Julieta Cortesini Leavi
 Dra. Marisa Segovia
 Dra. Laura Cuellar Niko
 Dra. Florencia Amigo
 Dra. Fabiola Rojas
 Dra. Geanella Chico Vergara
 Dra. María Cecilia Carozzo
 Dr. Alejandro Giamello
 Dr. Roberto Intani
 Dra. Marianela Boto
 Dra. Miriam Huanca
 Dra. Guadalupe Laime
 Dra. Angélica Palomino
 Dra. Nigel López
 Dra. Barrios Karen
 Dra. Shirley Huanca
 Dr. Fernando Bustamante
 Dra. Betty Martínez
 Dra. Lizz D. Arrieta Serrudo
 Dra. Agustina Masco
 Dra. María Martha Rottini
 Dra. Silvina Rocha
 Dra. Carla Abud
 Dra. Elena Vicente
 Dra. Juliana Safar
 Dra. Yanina Baibona
 Dra. Gina Batistelli
 Dr. Ari Santucho
 Dr. Carlos Gabriel Dinatale

Dra. María Eugenia Olivetti
 Dra. Paola Basualdo
 Dra. Mariangeles Cura
 Dra. María Laura Andornino
 Dra. Ana Belén Solillo
 Dra. Rebeca Flores
 Dra. Natalia Dadiago
 Dr. Cristian Sánchez Vocci
 Dra. C. Yevara
 Dra. S. Ruiz Barja
 Dr. Maximiliano Schianni
 Dra. M. Quayat
 Dra. M. Almirón
 Dra. R. Sánchez
 Dra. J. Kuschner
 Dra. Paola Basualdo
 Dra. Iara Chocron
 Dra. Carla Camacho
 Dra. Leila Menta
 Dra. Julieta Ciabattoni
 Dra. María Laura Andornino
 Dr. León Sandy Chaparro
 Dra. Gabriela Arakelian
 Dr. Jorge Larcamón
 Dr. Claudio Ambrosio
 Dra. Paola Basualdo
 Dra. María José Lobos
 Dra. Aldana Briceño
 Dra. Sandra Miranda
 Dra. Sofía Jiménez
 Dra. Mónica García
 Dra. Cecilia Gorriti
 Dra. Giselle Pérez
 Dra. Mariela A. Vilar Pereira
 Dr. Roberth Wagner Pazmiño
 Dra. Mariela Ríos
 Dr. Ezequiel Varela
 Dra. Érica Moreno
 Dra. Yanina Lagala
 Dr. Cristian Olivera
 Dra. Leticia Caballero
 Dra. Lizet Fernández
 Dra. Julieta Pardon
 Dra. Mara Maydana
 Dra. Itatí Bustamante
 Dra. Ana Elisa Wagner
 Dr. Néstor Cousté
 Dra. Ana Clara Martínez
 Dra. Paz Sánchez Paz
 Dra. Carla Carmona
 Dra. Julia Castello
 Dra. Carolina García
 Dra. Lorena Gianasio
 Dra. Anabella Lamberto
 Dra. Andrea Rodríguez
 Dr. Fausto Martín Ferolla

Dra. Ana M.Olmos
Dra. Elizabeth Fadda
Dr. Silvina Frino
Dr. Daniel Portero
Dra Gisela Marchetti
Dra. Jorgelina Mancha
Dra. Tania Salazar
Dra. Magdalena Galetovich
Dra. Elizabeth Vargas
Dra. Belén Pirloni
Dra. Fiama Schechtel
Dra. Agustina Zarantonelli
Dra. Soledad Martiren
Dra. Iara Chocron
Dra. Andrea Panozzo
Dra. María Belén Hunter
Dra. Soledad Ortiz López
Dra. María Agustina Parillo
Dr. Walter Barbosa
Dra. Natalia Bayaut
Dra. Cecilia M. Santolin
Dra. Natalin Grassi Llofriu
Dr. Martín Amigucci
Dr. Walter Barbosa
Dra. Mabel Kamuda
Dra. Soledad Cartasso
Dra. Eliana Pradejczuk
Dra. María de las Nieves Pereyra
Dr. Romel Camacho
Dra. Noelia Schreiner
Dr. Julio César Orcko Mamani
Dra. Mariana Tartabini
Dra. Lizet Oilos Ríos
Dra. Vilma Cardozo
Dra. Tatiana Alava
Dra. Magali Lopreiato
Dra. Florencia Di Miro
Dra. Ana Pamela Martin

Dra. Melina Cobre
Dra. Carolina Virginia Rita
Dra. Jacqueline Pallotta
Dra. Florencia Garavagna
Dra. Shirley Gallardo
Dra. Marisol Buezo
Dra. Eliana Julián
Dra. Carolina Abraldez
Dr. Rodrigo Nicolás Giralda
Dra. María Emilia Acevedo
Dra. Carina Yafar
Dra. Diana Cabanillas
Dra. Verónica Díaz
Dra. Estefanía Barsotti
Dra. Evelina Faraone Berlingeri
Dra. Carolina García
Dra. Estefanía Giménez Lanci
Dra. Florencia Belén Miloro
Dra. Andrea Rodríguez
Dr. Antelo Sebastián
Dra. Elizabeth Rizzo
Dr. Jonatan Ezequiel Rojas
Dra. María Emilia Breppe
Dra. Verónica Pisauri
Dra. Georgina Rossi
Dra. Alejandra Coca Salazar
Dr. Álvaro Zamo
Dra. Verónica Figueroa Gacitúa
Dra. Laura Diana Milgram
Dra. Analía Arturi
Dra. Rocío Ligo
Dra. Cecilia de la Vega
Dra. Florencia Menegazzo
Dra. Alejandra Leguizamo
Dr. Pablo Gallardo
Dra. Érica B. Cruz Glean
Dra. Lucia Cárdenas
Dra. Giselle Molina

Dra. Claire Delgadillo
Dr. Eric Berestein
Dra. María Del Rosario Mesiano
Dra. Rosario Barrales
Dr. Sebastián Irastorza
Dra. Cecilia Inés Luna
Dra. Marisa Fernández Cordero
Dra. Viviana Balbi
Dra. Verónica González
Dra. Emilia Breppe
Dra. Liliana Alfano
Dra. Eliana Maddaleno
Dr. Lionel Proietti
Dra. Julia Tamburini
Dra. Mercedes Villamil
Dra. Victoria Bordo
Dr. Juan Miguel Cotrofe
Dra. Lorena Dinunzio
Dra. Dana Dubny
Dra. Estefanía Leguizamón
Dra. Mariela Pelliza
Dra. Catalina Micaela Prieto
Dra. María Luisa Rossi Ortega
Dra. María Luisa Rueda Puelles
Dra. Lorena Inés Giménez
Dra. Julieta Priscila Pastorino
Dra. María Eugenia Frías
Dra. Nadia Bocon
Dra. Sofía Mores
Dra. Estefania Ortigosa
Dra. Josefina Rodríguez Eyra
Dra. Nereida Figueiredo
Dra. Karina Espada
Dra. Mercedes Zubigaray
Dra. Ileana Mastropierro
Dra. Florencia Bruggesser

ÍNDICE

— PRÓLOGOS

Dr. Mario Rovere..... Pág 23

Dr. Roberto Mateos..... Pág 25

— NÚCLEO EXPERTOS

1. Homenaje a los imprescindibles Pág 28

Prof. Dr. Juan Reichenbach

Prof. Dra. Patricia Ester Climent de Plaza

2. Reflexiones sobre la Pediatría Ambulatoria Pág 37

Dra. Fanny Breitman

3. El pediatra y la lactancia materna Pág 42

Dr. Gustavo H. Sager

**4. El lugar de la cultura en las interpretaciones
e intervenciones en salud** Pág 47

Antropóloga Prof. Dra. Susana Ortale

**5. Salud del niño, la niña y el adolescente desde
una perspectiva de derechos humanos** Pág 74

Prof. Dr. Juan Reichenbach

**6. Agua para el consumo de los niños: prácticas
de cuidado y percepción del riesgo a la salud
desde una mirada social** Pág 82

Lic. Valeria Andrea Belmonte

Lic. Liliana Mingillo

Dr. Jorge Luis Pepe

7. Semiología familiar Pág 91

Prof. Dr. Adalberto Enrique Palazzi

**8. Abordaje paliativo en neonatología,
subjektivando lo innombrable** Pág 97

Lic. Marianela Balanesi

Lic. Claudia Mónica García

**9. Cuidados Paliativos Perinatales ¿cuándo,
dónde y cómo?: algunas aproximaciones a su
implementación** Pág 108

Dra. Rut Kiman

Lic. Marianela Balanesi

10. **La red de perinatología en un municipio** Pág 117
Dr. Osvaldo Faustino Azpilicueta

11. **Cuidado integral de la salud bucal** Pág 125
Dra. Sara Fé de la Mella Quintero

12. **Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria: hacia un modelo de trabajo integrado en el primer nivel de atención** Pág 129
Dra. Jacqueline Ponzó
Dr. Walter Pérez

13. **Los programas de salud sexual y reproductiva y la maternidad adolescente en el partido de La Plata. Discusiones a la luz de los derechos humanos y el enfoque de género** Pág 140
Antropóloga Dra. Susana Ortale

14. **La construcción comunitaria de la salud. “Programa de Salud Pública Municipal INDIO SANO”, del Partido de Punta Indio** Pág 156
Prof. Dr. Juan Reichenbach

15. **El arte de la salud. Conversatorio sin tiempos** Pág 167
Prof. Dr. Juan Reichenbach

16. **Concepto DOHaD. Responsabilidad del equipo de salud en la salud de las futuras generaciones** Pág 177
Dr. Jorge L. Cabana
Dra. Stella Maris Gil

17. **Atención integral al niño, niña y adolescente** Pág 189
Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites

18. **Cuidar la salud infantil. Salud escolar en escuela rural de Hinojo** Pág 194
Manuel Acosta / Silvina Alcaza / Fiorella Bianchi /
Gonzalo Cabot / Pablo Cáceres / Lorena Caminos
/ María Fe Carreira Neto / Juan Emilio Ciancio /
Loana Cisneros / Salvador Consalvo / Nerina
Córsico / Joaquina Da Silva / Daiana Fernández /
Micaela Fígaro / Victoria Gómez Roldán / Bernabé
Herrera / Macarena Juárez / Kevin Lazarte / Lisandro
León / Sofía Porta / Carolina Quinteros / Victoria
Ramos / María de la Paz Sedano / Paula Vailati.
*Estudiantes de La Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires UNICEN.*
Dr. Juan Reichenbach
Dr. Héctor Trebucq
Dr. Carlos Prego
Lic. Maria Laura Catalano

Dra. Rosana Della Maggiora
Dra. María Esther Gatella
Dr. Gastón Seambelar
Esp. Daniela Pena
Expertos consultados y colaboradores

- 19. Una mirada a la APS desde el Hospital. Hospitalizaciones potencialmente evitables en Pediatría** Pág 206
Dr. Javier Ignacio Cabana
- 20. La construcción del conocimiento en la Facultad de Medicina** Pág 211
Dr. Franco Arzamendia
Dra. Alina Guarino
Dra. Ana María Sepulveda
- 21. Salud del niño, niña y adolescente, una mirada desde la currícula innovada** Pág 217
María Florencia Paiardini
Cintia Anabel Valdebenito
Camila Rosana Vignone
Dr. Franco Arzamendia
Dra. Alina Guarino
Dra. Ana María Sepulveda
Revisores
- 22. Mis luchas por la salud comunitaria** Pág 222
Prof. Dr. Horacio Pracilio
- 23. El encuentro con un niño sano, no sin conflictos** Pág 239
Dr. Fernando Alonso
- 24. Aportes para una investigación del crecimiento y desarrollo de los niños, sus familias y las redes de apoyo** Pág 246
Dr. Jorge Luis Pepe
Mg. bioq. Liliana Mingillo
Lic. en Salud Ambiental Claudia Rocca
Dra. Silvia Masini

**NÚCLEO
ESPECIALISTAS**

- 1. Llanto en el niño**..... Pág 255
Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites
- 2. Cambio de paradigma en la atención perinatal: ¿por qué seguimos resistiendo?**..... Pág 260
Lic. Marianela Balanesi
Dra. Martina Cisneros
Dra. Guadalupe García Monlezun

3. **Afecciones dermatológicas pediátricas más frecuentes en consultorios externos** Pág 267
Dra. Cintia Esquivel
Dra. Daniela Pereyra Bettoni
Dra. Claudia Chiavazza
Dra. Ianina Massimo. *Revisora*

4. **Vicios de refracción en pediatría** Pág 277
Dra. Sabrina Carme
Dra. Florencia Pruscino
Dra. Melisa Rubio
Dra. Daniela Gutiérrez
Dra. Sabrina Cicero
Dra. Karina Dueñas
Dra. Andrea Sancilio
Dra. Clarisa Menescaldi. *Revisora*

5. **La epilepsia en la edad escolar**..... Pág 282
Dr. Mauricio Pedersoli Castellani

6. **Inmunodeficiencias primarias. Generalidades y aspectos clínicos para el reconocimiento** Pág 289
Dr. Matías Oleastro

7. **Entrevista en el Adolescente** Pág 294
Dr. Pablo Gabriel Dei-Cas

8. **La consulta y el examen ginecológico en la niña y en la adolescente** Pág 300
Dr. Pablo Gabriel Dei-Cas

9. **El enmarañado diagnóstico de los problemas psíquicos en pediatría** Pág 305
Dr. Fernando Alonso

10. **Detección primaria de las cardiopatías** Pág 314
Dr. Ricardo Gamboa

11. **Diagnóstico precoz y derivación oportuna en niñas, niños y adolescentes con cáncer**..... Pág 319
Dra. Florencia Moreno
Dra. Emilse Andrea Caballero
Dra. María Cecilia Murray

12. **Infecciones pre y perinatales** Pág 338
Dra. Camila Ciganek
Dra. Mariana Esteves
Dra. Sabrina Flores
Dra. Marisa Golowczyc
Dra. Adriana León
Dra. Daniela Moya
Dra. Yésica Ramos

Dra. Mercedes Rocha
Dra. Ayelen Rojas Raies
Dra. Nora Patricia Mattarollo. *Revisora*

- 13. Dengue** Pág 356
Dr. Juan Carlos Daniel Morales
Dra. Marta Cecilia Vinuesa
- 14. Acerca del Covid 19 en Pediatría** Pág 363
Dr. Juan Carlos Daniel Morales
Dra. Marta Cecilia Vinuesa
- 15. Arritmias en pediatría** Pág 366
Dr. Jorge Bleiz
- 16. Enfermedades tiroideas en la infancia y adolescencia** Pág 373
Dra. Zulma Cristina Santucci
- 17. Cirugía ortognática** Pág 387
Dra. Daiana Pérez
Dr. Alejandro Ostrosky
- 18. Fracturas del macizo craneofacial en pacientes pediátricos** Pág 390
Dra. Elena Maidol
Dr. Alejandro Ostrosky
- 19. Espasmo del sollozo** Pág 394
Dra. Fabiana Pestchanker
Dra. Fernanda Nisimura
Dr. Diego Piñeyro
Dra. Marcela Koroluk
Dra. Natalia Di Pombo
Dra. Laura Idiart
Dra. Luz Mariel Suárez Lisperguer
Dra. Patricia Flores Cruz
Dr. Hedim Cristian Arias León
Dra. Karen Rita Simón Abularach
Dr. Mauricio Nava Ortega
Dra. Luciana Jimena Petraca. *Autora revisora*

**NÚCLEO
SITUACIONES
CLÍNICAS**

A. AFECCIONES DEL RECIÉN NACIDO

- 1. Recién nacido con aspiración de líquido amniótico meconial** Pág 398
Hospital Interzonal General de Agudos
Presidente Perón de Avellaneda
Dr. Néstor Ñique
Dra. Leticia Valenciano
Dra. Verónica Maldonado

Dra. Estefanía Otero
 Dr. Alejandro Oleiro
 Dra. Carolina Pérez
 Dra. Silvana Iriarte
 Dra. Ayelén Crespo
 Dr. Ángel Gabriel Mascó. *Revisor*

2. Enfermedad de membrana hialina Pág 404

Hospital Zonal General de Agudos Isidoro
 G. Iriarte de Quilmes.
 Dra. Julieta Cortesini Leavi
 Dra. Mariela Iori
 Dra. Pamela Ecos Fernández
 Dra. Luciana Ourracariet
 Dra. Valeria Blois
 Dra. Marisa Segovia
 Dr. Alejandro Cruz Carrozzo
 Dra. Laura Cuellar
 Dr. Niko Arredondo Rincón
 Dr. Juan Esteban Amigo
 Dra. Florencia Chica Vergara
 Dra. Fabiola Genilla Rojas
 Dra. M. Carozzo
 Dr. Eduardo Ariel Otero. *Revisor*

3. a. Termorregulación en el recién nacido Pág 410
b. Recién Nacido Febril Pág 413

Hospital Héctor Cura de Olavarría.
 Residencia Pediátrica.
 Dra. Anabella Coronel
 Dra. Daiana Gallo
 Dra. Jesica Menón
 Dr. Gabriel Teuly
 Dra. Alejandra Capriata. *Experta revisora*

B. AFECCIONES RESPIRATORIAS

1. Sibilancias Recurrentes en el niño menor de 3 años Pág 419

Hospital Zonal General de Agudos
 “Dr. Lucio Meléndez” de Adrogué.
 Servicio de pediatría.
 Dra. Sonia A Batiuk
 Dra. María Agustina Lagomarsino
 Dra. María de la Paz Ferrín
 Dr. Nicolás Cora
 Dr. Juan Gagnetten. *Revisor*
 Dr. Luciano Alva Grimaldi. *Revisor*

2. Manejo integral del asma infantil Pág 427

Dr. Néstor Pisapia

- 3. Tuberculosis pulmonar primaria grave. Niño de 4 años con síndrome febril y tos persistente** Pág 431
Hospital Municipal de Morón.
Residencia de Clínica Pediátrica
Dra. Paula Inés Villalba
Dra. Mariana Rotolo
Dra. Natalia Cuevas
Dra. Isabel Squazzi. *Revisora*

- 4. Experiencia con terapia de Alto flujo de oxígeno (TAFO) en 100 niños con bronquiolitis en una sala de internación** Pág 444
Dra. Cristina Ciriaci

C. AFECCIONES GASTROINTESTINALES

- 1. Dolor abdominal recurrente** Pág 447
Hospital Materno Infantil Tetamanti de Mar del Plata.
Dra. Cristina Ciriaci
Dra. Deysi Campos
Dra. Gabriela Capovilla
Dra. Antonella Colaneri
Dra. Gabriela Domijan
Dra. Melina Leppski
Dra. Natalia Pereyra
Dr. Leandro Rodríguez
Dra. Sandra Scarafoni. *Revisora*

- 2. Hemorragia Digestiva en Pediatría** Pág 452
Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela. Residencia de Pediatría.
Dr. Lucas Ruíz
Dra. Justina Salvatierra González
Dra. Viviana Bernedo. *Revisora*

- 3. Hepatitis virales** Pág 459
Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón de San Martín. Servicio de Pediatría.
Dra. Antonella Soledad Antonelli Sanz
Dra. María Candela Cogley
Dr. Leonel Romero Roldán
Dra. María Cecilia Eiras
Dra. María Lorena Cavalieri. *Revisora*

- 4. Enfermedad diarreica aguda** Pág 470
Hospital Municipal Eva Perón de Merlo.
Residencia de Pediatría.
Dra. Silvia Torrez
Dra. Inés Ivana Barrero Valdez
Dra. Viviana Lasso

D. AFECCIONES ODONTOLÓGICAS

- 1. Abscesos secundarios a caries dental en pediatría** Pág 476
Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de La Vega.
Od. Juana Bianchi
Dr. Alejandro Ostrosky

E. AFECCIONES DE LA PIEL Y ARTICULARES

- 1. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas** Pág 480
Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. Servicio de Pediatría.
Dra. Cintia Barrientos
Dra. Soledad Corizzo
Dra. María Florencia González
Dra. Sofía Riccardi
Dra. María Cristina Portela. *Revisora*
- 2. Displasia del desarrollo de la cadera** Pág 489
Hospital Interzonal General de Agudos
Dr. Isidoro Iriarte. Residencia de Clínica Pediátrica.
Dra. Pamela Ecos Fernández
Dra. Luciana Ourracariet
Dr. Juan Esteban Arredondo Rincón
Dra. Mariela Iori
Dra. Valeria Blois
Dr. Alejandro Cruz Carozzo
Dra. Julieta Cortesini Leavi
Dra. Marisa Segovia
Dra. Laura Cuellar Niko
Dra. Florencia Amigo
Dra. Fabiola Rojas
Dra. Geanella Chico Vergara
Dra. María Cecilia Carozzo
Dr. Alejandro Giamello. *Revisor*

F. AFECCIONES DE LA NUTRICIÓN

- 1. Desnutrición y Baja Talla** Pág 496
Hospital Zonal General de Agudos.
Héroes de Malvinas de Merlo. Servicio de Pediatría.
Dr. Roberto Intani
Dra. Marianela Boto
Dra. Miriam Huanca
Dra. Guadalupe Laime
Dra. Angélica Palomino
Dra. Nigel López
Dra. Karen Barrios

Dra. Shirley Huanca
Dr. Fernando Bustamante
Dra. Betty Martínez

2. Síndrome Metabólico Pág 517

Hospital Zonal General de Agudos Mariano y
Luciano de La Vega
Dra. Adriana Magne
Dra. Lizz D. Arrieta Serrudo
Dra. Agustina Masco

G. AFECCIONES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

1. ¿Por qué no pensar en cardiopatías? Pág 521

Hospital Interzonal General de Agudos San José
de Pergamino. Servicio de Pediatría.
Dra. María Martha Rottini
Dra. Silvina Rocha
Dra. Carla Abud
Dra. Elena Vicente
Dra. Juliana Safar
Dra. Yanina Baibona
Dra. Gina Batistelli
Dr. Ari Santucho
Dr. Carlos Gabriel Dinatale. *Revisor*
Dra. María Eugenia Olivetti. *Revisora*

**2. Cardiopatías asociadas a Síndromes
polimalformativos y a enfermedades sistémicas Pág 530**

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C.
de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Clínica Pediatría.
Dra. Paola Basualdo
Dra. Mariangeles Cura
Dra. María Laura Andornino
Dra. Ana Belén Solillo
Dra. Rebeca Flores
Dra. Natalia Dadiago
Dr. Cristian Sánchez Vocci. *Revisor*

3. Insuficiencia cardíaca Pág 536

Hospital Mercante de José C. Paz.
Dra. C. Yevara
Dra. S Ruiz Barja
Dr. Maximiliano Schianni
Dra. M. Quayat

4. Miocardiopatías Pág 539

Hospital Mercante de José C. Paz.
Dra. M. Almirón
Dra. R. Sánchez
Dra. J. Kuschnir

Dr. M. Schianni
Dra. M. Quayat. *Revisora*

5. Pericarditis Pág 543

Hospital Mercante de José C. Paz.
Dra. J. Kuschmir
Dr. M. Schianni
Dra. M. Quayat. *Revisora*

6. Hipertensión arterial en la infancia Pág 550

Hospital Zonal General de Agudos General
Manuel Belgrano de San Martín.
Dra. María Sol Cicero Moroni
Dr. Álvaro Enrique Pinto Merett
Dr. Daniel José Mogues. *Revisor*

H. AFECCIONES DEL TRACTO GENITOURINARIO

1. Síndrome urémico hemolítico Pág 557

Hospital Interzonal General de Agudos
Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría.
Dra. Paola Basualdo
Dra. Iara Chocron
Dra. Carla Camacho
Dra. Leila Menta
Dra. Julieta Ciabattini
Dra. María Laura Andornino
Dr. León Sandy Chaparro
Dra. Gabriela Arakelian. *Revisora*

2. Síndrome nefrítico Pág 562

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa
C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría.
Dr. Jorge Larcamón
Dr. Claudio Ambrosis
Dra. Paola Basualdo
Dra. María José Lobos
Dra. Aldana Briceño
Dra. Sandra Miranda
Dra. Sofía Jiménez
Dra. Gabriela Arakelian. *Revisora*

3. Síndrome nefrótico Pág 569

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa
C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría.
Dr. Jorge Larcamón
Dra. Adelma Herrera
Dra. Paola Basualdo
Dra. Mónica García

Dra. Cecilia Gorriti
Dra. Giselle Pérez
Dra. Mariela A. Vilar Pereira
Dr. Roberth Wagner Pazmiño
Dra. Mariela Ríos. *Revisora*
Dr. Ezequiel Varela. *Revisor*

I. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1. Reconocimiento temprano de la Sepsis en Pediatría Pág 576

Hospital General Zonal de Agudos Mi Pueblo
de Florencio Varela. Residencia de Clínica Pediátrica.
Dra. Érica Moreno
Dra. Yanina Lagala
Dr. Cristian Olivera
Dra. Leticia Caballero
Dra. Lizet Fernández
Dra. Julieta Pardon
Dra. Mara Maydana. *Revisora*

2. Meningitis y meningoencefalitis en Pediatría Pág 584

Hospital General Zonal de Agudos Mi Pueblo
de Florencio Varela. Residencia de Clínica Pediátrica.
Dra. Érica Moreno
Dra. Yanina Lagala
Dr. Cristian Olivera
Dra. Leticia Caballero
Dra. Lizet Fernández
Dra. Julieta Pardon
Dra. Mara Maydana. *Revisora*

3. Enfermedades de transmisión sexual Pág 590

Hospital Zonal General de Agudos Argentina
Diego de Azul.
Dra. Itatí Bustamante
Dra. Ana Elisa Wagner
Dr. Néstor Cousté
Dra. Ana Clara Martínez. *Revisora*
Dra. Paz Sánchez Paz. *Revisora*

4. Fiebre sin foco en el niño de 3 a 36 meses Pág 599

Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado
“Evita Pueblo” de Berazategui.
Dra. Carla Carmona
Dra. Julia Castello
Dra. Carolina García
Dra. Lorena Ganasio
Dra. Anabella Lamberto
Dra. Andrea Rodríguez
Dr. Fausto Martín Ferolla. *Revisor*

5. Vacunas. Oportunidades perdidas	Pág 604
Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro de Junín. Residencia de Clínica Pediátrica.	
Dra. Ana M. Olmos	
Dra. Elizabeth Fadda	
Dr. Silvina Frino	
Dr. Daniel Portero	
Dra. Gisela Marchetti	
Dra. Jorgelina Mancha	
Dra. Tania Salazar	
Dra. Magdalena Galetovich	
Dra. Elizabeth Vargas	
Dra. Belén Pirloni	
Dra. Fiama Schechtel	
Dra. Agustina Zarantonelli	
Dra. Soledad Martiren. <i>Revisora</i>	
 J. AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	
1. Examen neurológico en pediatría	Pág 608
Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. Servicio de Pediatría.	
Dr. Jorge Larcamón	
Dra. Paola Basualdo	
Dra. Iara Chocron	
Dra. Andrea Panozzo	
Dra. María Belén Hunter	
Dra. Soledad Ortiz López	
Dra. María Agustina Parillo	
Dr. Walter Barbosa. <i>Revisor</i>	
Dra. Natalia Bayaut. <i>Revisora</i>	
 2. Cefaleas en Pediatría	Pág 618
Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela.	
Residencia de Clínica Pediátrica	
Dra. Cecilia M. Santolín	
Dra. Natalin Grassi Llofriu	
Dr. Martín Amigucci	
Dr. Walter Barbosa. <i>Revisor</i>	
 3. a. Eventos paroxísticos epilépticos y no epilépticos.....	Pág 623
b. Ataxia	Pág 629
Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien. Servicio de Pediatría.	
Residencia de Clínica Pediátrica.	
Dra. Mabel Kamuda	
Dra. Soledad Cartasso	
Dra. Eliana Pradejczuk	
Dra. María de las Nieves Pereyra	
Dr. Romel Camacho	

Dra. Noelia Schreiner
 Dr. Julio César Orcko Mamani
 Dra. Mariana Tartabini
 Dra. Lizet Oilos Ríos
 Dra. Vilma Cardozo
 Dra. Tatiana Alava
 Dra. Magalí Lopreiato
 Dra. Florencia Di Miro
 Dra. Ana Pamela Martin
 Dra. Melina Cobre
 Dra. Carolina Virginia Rita
 Dra. Jacqueline Pallotta
 Dra. Florencia Garavagna
 Dra. Shirley Gallardo
 Dra. Marisol Buezo
 Dra. Julian Eliana. *Revisora*

- 4. Síndrome de West** Pág 633
 Lactante de 5 meses con movimientos de flexión
 simultánea y rítmica de cabeza y piernas.
 Hospital Zonal General de Agudos Dr. R. Carrillo
 de Ciudadela. Residencia de Clínica pediátrica.
 Dra. Carolina Abralles

K. AFECCIONES ONCOLÓGICAS

- 1. Tumores del sistema nervioso central** Pág 638
 Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.
 Residencia de Clínica Pediátrica.
 Dr. Rodrigo Nicolás Giralda
 Dra. María Emilia Acevedo
 Dra. Carina Yafar
 Dra. Diana Cabanillas
 Dra. Verónica Díaz. *Revisora*

- 2. Detección precoz de patología oncológica infantil. “El que busca encuentra”** Pág 642
 Hospital Zonal General de Agudos “Evita Pueblo”
 de Berazategui. Servicio de pediatría. Residencia
 de Clínica Pediátrica.
 Dra. Estefanía Barsotti
 Dra. Evelina Faraone Berlingeri
 Dra. Carolina García
 Dra. Estefanía Giménez Lanci
 Dra. Florencia Belén Miloro
 Dra. Andrea Rodríguez
 Dr. Sebastián Antelo. *Revisor*

L. MISCELÁNEAS

- 1. Desarrollo puberal** Pág 647
 Hospital General de Agudos Magdalena V. de
 Martínez de Pacheco. Servicio de Pediatría.

Dra. Elizabeth Rizzo
Dr. Jonatan Ezequiel Rojas
Dra. María Emilia Breppe. *Revisora*

2. Pubertad precoz y tardía Pág 653

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa
C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría.
Dra. Verónica Pisauri
Dra. Georgina Rossi
Dra. Alejandra Coca Salazar
Dr. Álvaro Zamo
Dr. Jorge Larcamón
Dra. Verónica Figueroa Gacitúa. *Revisora*
Dra. Laura Diana Milgram. *Revisora*

3. Maternidad adolescente Retos actuales en la práctica pediátrica Pág 663

Hospital Zonal de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez
de La Plata. Residencia de Pediatría.
Dra. Analía Arturi
Dra. Marta Vinuesa
Dra. Rocío Ligo
Dra. Cecilia de la Vega
Dra. Florencia Menegazzo

4. Abuso, maltrato y negligencia infantil Pág 670

Hospital Interzonal General de Agudos
“Dr. Alberto Eurnekian” de Ezeiza. Servicio de
Pediatría. Internación. Residencia de Clínica Pediátrica.
Dra. Alejandra Leguizamo
Dr. Pablo Gallardo
Dra. Érica B. Cruz Galian
Dra. Lucía Cárdenas
Dra. Giselle Molina
Dra. Claire Delgadillo
Dr. Eric Berestein
Dra. María Del Rosario Mesiano. *Revisora*

5. Insuficiencia Suprarrenal Aguda Pág 676

Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra
de La Plata. Unidad de Residencia de Pediatría.
Dra. Rosario Barrales
Dr. Sebastián Irastorza
Dra. Cecilia Inés Luna
Dra. Marisa Fernández Cordero
Dra. Viviana Balbi. *Revisora*
Dra. Verónica González. *Revisora*

6. Hirsutismo e hipertrichosis Pág 681

Hospital Municipal Materno Infantil de Tigre
Dr. Florencio Escardo.

Residencia de Clínica Pediátrica.
Dra. Emilia Breppe
Dra. Liliana Alfano
Dra. Eliana Maddaleno
Dr. Lionel Proietti
Dra. Julia Tamburini
Dra. Mercedes Villamil
Dra. Victoria Bordo

7. Tecnología 10. Humanidad 0 Pág 686
Dr. Juan Miguel Cotrofe

8. Golpe de calor Pág 688
Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría.
Servicio de pediatría. Residencia de pediatría.
Dra. Lorena Dinunzio
Dra. Dana Dubny
Dra. Estefanía Leguizamón
Dra. Mariela Pelliza
Dra. Catalina Micaela Prieto
Dra. María Luisa Rossi Ortega

9. Vulvovaginitis Infantil Pág 694
Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson de
San Martín. Residencia de Pediatría.
Dra. Daniela B. Filippo
Dra. María Luisa Rueda Puelles
Dra. Lorena Inés Giménez
Dra. Julieta Priscila Pastorino
Dra. María Eugenia Frías

10. Fiebre de origen desconocido Pág 702
Hospital de Niños Debilio Villegas de Tandil.
Dra. Nadia Bocon
Dra. Sofía Mores
Dra. Estefanía Ortigosa
Dra. Josefina Rodríguez Eyras
Dra. Nereida Figueiredo
Dra. Karina Espada
Dra. Mercedes Zubigaray
Dra. Ileana Mastropierro
Dra. Florencia Bruggesser. *Revisora*

EPÍLOGO

Prof. Dr. Juan Reichenbach Pág 709

PRÓLOGO

MARIO ROVERE*

Juan Reichenbach lo volvió a hacer, con su paciencia, con su capacidad de hilar y de tejer voluntades y con su inquebrantable vocación docente ha vuelto a producir eso que al decir de Deleuze es, en última instancia la esencia de un libro: el devenir en una verdadera caja de herramienta.

Son tiempos muy especiales, una temible pandemia ha cambiado nuestras formas de vivir, de relacionarnos, de crecer y de cuidar, incluso nuestras prioridades y los niños, las niñas y les adolescentes parecen no estar en el centro de gravedad de las preocupaciones cotidianas. Parecen estadísticamente poco afectados en forma directa por el SARS Covid19, que en pocos meses puso en jaque a la humanidad, pero esta es una verdad a medias. Los grandes hospitales pediátricos registran diariamente pacientes, en algunos casos de gravedad de niños afectados con manifestaciones variadas asociadas al Coronavirus e incluso algunas nuevas patologías autoinmunes que recuerdan el Síndrome de Kawasaki parecen asociadas al Covid 19 (Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico).

Las preocupaciones alcanzan entonces a la niñez pero resultan aún más acentuadas cuando nos desplazamos desde la epidemia a las consecuencias de la alta focalización en una única enfermedad y a las prolongadas medidas cuarentenarias.

Bastaría para ello mencionar la ausencia de actividad escolar, la suspensión de diversos servicios considerados por la población y por los propios hospitales como “no esenciales”, el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, el infundado aislamiento de las mujeres en trabajo de parto, las cesáreas “inne-cesáreas” y su negativo impacto en la salud de la mujer y el recién nacido, el marcado ausentismo en los controles de salud, la demora en las consultas desoyendo claros signos de alarma, la reducción de la cobertura de las actividades preventivo-promocionales, todo ello en función de las

precauciones y de los temores que sugieren una postergación sin plazos de las precauciones y que puede sorprendernos con la ampliación y multiplicación de problemas de salud que hoy permanecen transitoriamente fuera de la visibilidad de la epidemiología y de la política pública.

Pero los números de la pobreza parecen señalar que si lo normal es lo más frecuente, lo normal es que un niño o niña sea pobre en la Argentina; a pesar del enorme subsidio que estabiliza la realidad social en plena pandemia, las estimaciones de UNICEF indican que a fin de año un 62,5 % de la niñez se encontrará en situación de pobreza lo que representa en números absolutos alrededor de 8.300.000 niños y niñas.

Ser pobre no es un problema contextual, la pobreza se mide en función del precio de la canasta alimentaria, en consecuencia, la pobreza y más aun la indigencia representan por si mismas un indicador de salud y de nutrición.

La propia práctica de la pediatría se ve afectada en este complejo escenario y el lanzamiento de esta nueva obra, justo en este momento, representa un mensaje, un llamado a recuperar iniciativa en el cuidado de nuestras nuevas generaciones.

Hace mucho tiempo en los comienzos mismos de mi práctica pediátrica me llamaba la atención la existencia de tantas obras nacionales de la especialidad -lo que por entonces no era nada frecuente en otras especialidades- y esos textos aportaban una combinación única de temas médicos, psicológicos, culturales y sociales. Textos que acompañaban con un lenguaje sencillo, con reflexiones y con datos propios una práctica pediátrica adaptada a nuestras realidades.

La salud de los niños, niñas y adolescentes es un campo complejo y no debe extrañar la proliferación de abordajes interdisciplinarios y campos de reflexión que muchos considerarían, con argumentos, por fuera de la corriente identitaria de la profesión médica.

La obra que estudiantes, profesionales y lectores

interesados en general tienen hoy entre manos representa justamente eso: una verdadera cartografía de la práctica de la pediatría general hoy.

El Ministerio de Salud de la Provincia y su histórica Escuela de Sanidad, hoy rebautizada y lanzada al futuro como Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” ha contado y cuenta -a pesar de un involuntario intervalo- con un profesional, con un pediatra, con un profesor que ha hecho de la producción y circulación del conocimiento una verdadera identidad, trabajando incansablemente en repositorios digitales, en textos, y en obras de distinto porte otorgando una identidad al rol de rectoría del Ministerio en las residencias pediátricas que con gusto nos gustaría extender a otras profesiones y especialidades.

Compartimos con Juan la convicción que las residencias son la mejor propuesta de formación de posgrado para los y las profesionales de salud, pero también compartimos que ello es cierto, solo a condición, que, las residencias sean académicamente supervisadas para lograr esa combinación virtuosa de compromiso y rigurosidad que el sistema formativo impone.

La idea de Gobierno en la denominación de la Escuela podría dejar la errónea impresión que el centro de gravedad de la institución se ha alejado de la formación clínica. Al contrario, el claro mandato que surge del Decreto que la crea es el de articular y potenciar las diversas fuentes de conocimiento en una lógica que hoy se expresa en orientaciones como la de investigación traslacional que en su sentido más amplio obliga a articular lo básico con lo clínico, lo biológico con lo social, lo individual con lo colectivo y estas ricas combinaciones son exactamente lo que se observa en esta obra que tienen Uds. a disposición.

La apelación al anglicismo traslacional (que proviene del inglés traslation: traducción) puede resultar en si mismo un objeto de reflexión. En cualquier sistemas de ideas existe, lo que Pichon Riviere llamaba, un Esquema Conceptual Referencial y Operativo (ECRO) que puede ser específico de cada profesión, de cada especialidad, de cada contexto institucional; en ese contexto se producen ECROs que al mismo tiem-

po que construyen identidad, aíslan generando estancos de conocimiento que se acumulan con escaso aprovechamiento transversal y así a pesar del crecimiento exponencial de los trabajos científicos un número creciente de objetos complejos quedan muy lejos del foco o de la corriente principal de la producción de conocimiento.

Los traductores profesionales, una ayuda y compañía tan silenciosa como imprescindible en los congresos internacionales, prefieren ser llamados intérpretes ya que es esa una palabra que describe mucho mejor la complejidad de su tarea. Pero seremos nosotros capaces de ser no solo traductores sino incluso interpretes capaces de conectar por ejemplo los diferentes capítulos de esta obra, sin limitarnos a buscar, como en un Congreso, solo aquello que nos interesa, aquello que nos espeja.

Que podríamos sino pensar cuando recorremos el índice de esta obra y vemos convivir temas clínicos con temas sociales y otros de neto corte comunitario, temas de bioética y derechos humanos con competencias situacionales en un tejido que serviría ciertamente para que algún analista externo al propio campo intentara resolver la pregunta ¿Qué es la pediatría hoy?, ¿Cómo se construye y deconstruye la salud de niños, niñas y adolescentes a 30 años de la Declaración de los derechos del niño y a 25 de su incorporación en el orden constitucional argentino?

Pero, sobre todo, la tarea de Juan, convocando y liderando este colectivo de calificados autores es como siempre el de proponer una obra abierta, una obra abierta al tiempo, a los nuevos desafíos, a las nuevas preguntas y a los nuevos conocimientos que logren desplazar a la declaración universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes del espacio de las deudas, de los deseos y de las promesas hacia el de las realidades concretas, en esa nueva normalidad post-pandemia, que ahora mismo debemos sembrar.

***DR. MARIO ROVERE**

Director Provincial Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

PRÓLOGO

DR. ROBERTO JOSÉ MARÍA MATEOS*

***“la necesidad de pensamiento
es lo que nos hace pensar”
Theodor W Adorno.***

La presentación de un nuevo libro siempre se considera un hecho auspicioso. En este caso al referirse a la salud integral de niños, niñas y adolescentes cobra vital trascendencia. El contenido del mismo resulta apasionante, ya que posibilita convertir a todos los recién nacidos en seres humanos sanos y con buena calidad de vida. Merece un elogio especial esta nueva obra interdisciplinaria de Juan Reichenbach realizada con la colaboración de expertos, especialistas y relatores de situaciones clínicas, que con su saber y experiencia en las respectivas temáticas han desarrollado las mismas en forma coherente y didáctica. Con Juan hemos transitado juntos instituciones, sociedades científicas, congresos de pediatría y ámbitos docentes, lo que me permitió percibir inmediatamente su calidad humanística, su seriedad científica, su espíritu constructivo y su pasión por la búsqueda de soluciones a los padecimientos de los infantes y jóvenes. Repitiendo palabras de Noel Sbarra digo que Juan “supo apartarse de la regla común y encontrar nuevos derroteros para ejercer la pediatría con proyección social, un arte que es tan antiguo como el dolor”. Todo eso lo explicita con claridad meridiana en el texto.

La niñez y juventud sufren en estos tiempos gravísimas situaciones de desigualdad social, precariedad educativa y vulnerabilidad familiar y comunitaria que influyen decisivamente en su crecimiento y desarrollo normal. Peligra por lo tanto su presente y su futuro. Es urgente e imprescindible modificar esta dramática circunstancia. Aquí y ahora a nivel local, regional y nacional. El libro constituye una excelente herramienta con los conocimientos que nos brinda

para ayudar a cambiar. Nos estimula a “desaprender” la inacción. Comencemos hoy este duro desafío, no podemos permanecer indiferentes. No hacerlo sería imperdonable. Respetemos sin claudicaciones los Derechos Universales del Niño y las leyes que los protegen.

Las estrategias y acciones que los autores nos proponen están orientadas a promover estilos de vida saludables, prevenir morbilidades y sus secuelas, indicar terapéuticas racionales y evitar riesgos vitales. Nos orienta que son primordiales: la gestación óptima, el nacimiento en instituciones sanitarias y el control periódico de su crecimiento y desarrollo. Los autores del libro coinciden con Florencio Escardo cuando escribió “para enseñar no basta saber, ni siquiera saber enseñar, hay que además querer enseñar”. Ellos intentan ayudar con sus propuestas en la búsqueda de soluciones viables y concretas para la encrucijada humana que muchos niños sufren actualmente. El saber pediátrico necesita, como nos propone el texto, de los conocimientos científicos y tecnológicos actualizados, pero requiere también prudencia para discernir y coloquialidad comunicacional afectiva con los otros para comprender sus sufrimientos. No olvidemos que debemos desempeñar nuestro oficio como una tarea convivencial. Intensifiquemos nuestra labor cotidiana humanizada y humanizante sin renunciamentos.

El desamparo, la soledad y la fragilidad en la que viven gran parte de la población infanto-juvenil, nos obliga a encontrar sin demora respuestas acertadas para colaborar a mitigar esta ingrata coyuntura. Nada de todo lo propuesto será posible concretar con recursos municipales, provinciales y nacionales insuficientes y con salarios exigüos para todo el equipo de salud. Se hace indispensable valorar la trascendente labor que desempeñan. La singular combinación

de racionalidad, sensatez y sentimientos presidirá el ejercicio cotidiano de quienes estamos en contacto permanente con los niños, niñas, adolescentes y sus entornos familiares. Nunca olvidemos que el difícil proceso de curación está siempre influenciado por los intrincados vínculos de la comunicación interhumana.

Los que tenemos el enorme privilegio de cultivar el porvenir de la infancia y la juventud debemos tener siempre presente estos conceptos para que puedan disfrutar de una vida equilibrada y equitativa colmada de bienestar y salud.

Reconocimiento permanente en nombre de todos los niños niñas, adolescentes y en el mío propio, para Juan Reichenbach, los autores de capítulos y a todos los que colaboraron en las diferentes áreas con inquebrantable afán para la edición de esta magnífica obra. Gracias por enseñarnos con firme convicción a no ser prescindentes y a no subestimar la existencia de la niñez de hoy y de siempre sin exclusiones de ningún tipo. Los niños, niñas y adolescentes no merecen ser los olvidados del sistema de salud público y privado. Nada deberá ser antes ni primero que ellos.

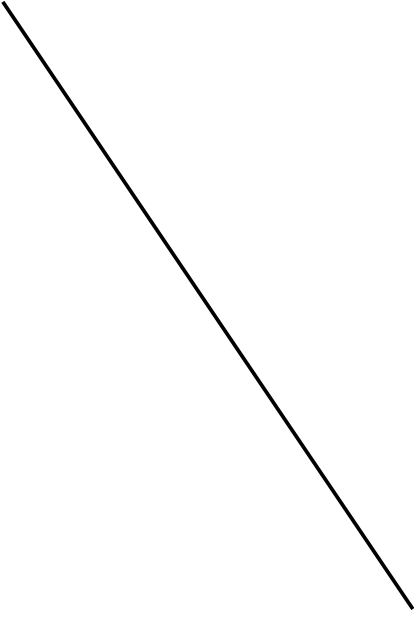
***DR. ROBERTO JOSÉ MARÍA MATEOS**

Médico pediatra. Especialista consultor.

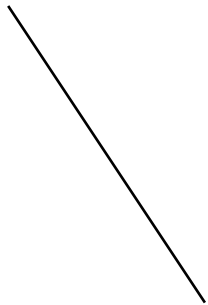
Ex director ejecutivo Hospital Dr. Noel Sbarra de La Plata

Ex profesor titular “Cátedra B” de Pediatría Facultad de Ciencias Médicas UNLP

Miembro honorario nacional SAP.



NÚCLEO **EXPERTOS**



RECREANDO A LOS IMPRESCINDIBLES



PROF. DRA. PATRICIA ESTER CLIMENT DE PLAZA*
PROF. DR. JUAN REICHENBACH**

Desde el incipiente renacimiento del *Portal de Educación Permanente en Pediatría (bautizado) Prof. Dr. Vicente Climent* y desde *Pediatría en Red 3*, ambos en el ámbito de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dirigida por su creador el Dr. Mario Rovere, creemos en aquello de revisar la historia, de encontrar los orígenes, reconocer nuestras identidades, homenajear a nuestros maestros. A nuestros padres académicos e ideológicos.

Y es en este punto donde quiero reparar. En el caso específico de la formación en el grado y en el posgrado pediátrico, en las residencias, en los hospitales de la especialidad, en los centros de atención y en las comunidades. Sin duda la ciu-

dad de La Plata consolidó una escuela de salud reconocida en el país y en el mundo, de la talla de las generadas en otros centros nacionales.

Las nuevas generaciones del equipo de salud necesitan rescatar las imágenes del origen, las actitudes y aptitudes de los pioneros. Los que tuvimos el privilegio de escucharlos, de aprender, de compartir noches interminables y feriados frecuentes en la oscuridad de una sala o en la luz de un paraje olvidado, percibimos que comprender la salud de nuestros niños excede los papers, las normas y el pase de sala de la media mañana. Habita humanos con pasión, seres de luz y de absoluta integralidad, de vocación por la sonrisa y los derechos en lucha eterna por la equidad.



VICENTE CLIMENT

PROF. DRA. PATRICIA ESTER CLIMENT DE PLAZA*



*“Todos los niños, tienen el derecho a la salud y a la atención de máxima calidad, independientemente de su clase social”.
Prof. Dr. Vicente Climent*

Patricia Ester Climent de Plaza (una de sus hijas) y Juan Reichenbach conversan sobre Vicente Climent

– Hola Patricia, necesitamos que nos cuentes acerca de tu padre, de sus orígenes, de su educación inicial, de su vida universitaria.

Mi padre nació prematuramente en La Plata el 11 de Julio de 1917 en el seno de una familia de inmigrantes españoles analfabetos. Fue el primero de los cuatro hijos de Carmen González y Vicente Climent, de quienes heredó el culto al trabajo, la honestidad, responsabilidad y respeto al prójimo sin diferencias sociales. Fue pro-

ducto de la educación pública y siempre recordó a los docentes que influyeron en su vida profesional. En la Escuela nº 10 a su maestra de 3º Grado, la señora Ofelia Ocampo de Pera, poetisa. Ya en el Colegio Nacional de La Plata, al gran Ezequiel Martínez Estrada, uno de los poetas más grandes de su generación. En Medicina, al Dr. Felipe Cieza Rodríguez (Profesor Titular de Medicina Interna de la UNLP).

Se graduó en la Facultad de Medicina el 27 de Noviembre de 1945, donde posteriormente realizó el Doctorado en Medicina.

– ¿A qué se dedicaban tu madre y tus hermanos?

Mis padres se casaron en 1947. Mi madre Esther Virginia Giovanola, maestra de escuela primaria, supo acompañar su actividad sin interponer la vida familiar al desarrollo profesional de papá, reconociendo la importante función social que

cumplía. Sus cuatro hijos somos médicos: Juan Carlos (neonatólogo), Gabriela (diagnóstico por imágenes en Pediatría), Claudio Sergio (obstetra y ginecólogo) y yo, Patricia (neonatóloga).

– *¿En qué subsector desarrolló su actividad asistencial?*

Desarrolló su actividad asistencial solo en el hospital público.

Comenzó como médico clínico en el Dispensario de la Asistencia Pública, que es la actual *Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara*. En poco tiempo se orientó hacia la Pediatría, iniciándose como médico concurrente ad honorem en la Sala II del Hospital de Niños de La Plata. Ingresó a la Carrera Médica Hospitalaria por concurso en el año 1952, a los 35 años. A los 40 años ya era Jefe de la Sala V del Servicio de Lactantes y en 1972 Jefe de Servicio de Recién Nacidos.

Era un tenaz trabajador dedicado permanente y exclusivamente al ámbito hospitalario.

Fue el creador del Servicio de Recién Nacidos del Hospital de Niños de La Plata el 27 de septiembre de 1972. Este servicio estaba estructurado en cuatro divisiones: asistencial, docente, investigación y adiestramiento. En el Área Asistencial, el Servicio contaba con una Sala de Esterilización automatizada, biberonería, Laboratorio, Quirófano, Electroencefalografía y Electrocardiografía, Radiología, Consultorio externo, Biblioteca con 800 volúmenes, Sala de reuniones y un sistema cerrado de televisión que permitían un control permanente de todos los pacientes desde el estar médico y de enfermería con posibilidad de grabación de videotapes sonoros de todas las actividades y casos de interés docente y científico.

El diagnóstico radiológico y la importancia del Laboratorio y la Bacteriología los afianzó con un aparato de rayos portátil y equipos de medición de pH que él y sus médicos residentes, concurrentes y becarios utilizaban a diario.

El Servicio de Neonatología con Terapia Intensiva Neonatal y la posibilidad de la Asistencia Mecánica Respiratoria fue el primero de la provincia y por él rotaron profesionales prestigiosos como el Dr. Miguel Larguía.

– *¿Cómo era su actividad, sus días?*

Era un apasionado... Por ejemplo... le encantaba la cirugía neonatal.

Realizó el diagnóstico de todo tipo de malformaciones quirúrgicas y presenciaba las intervenciones quirúrgicas a cualquier hora del día y de la noche.

Fue un pionero en la práctica de la autopsia y la realizaba con sus discípulos cuando un recién nacido fallecía sin un diagnóstico claro. El hospital funcionaba las 24 horas y la necesidad del trabajo interdisciplinario con distintos especialistas, que en aquella época parecían una utopía, pudo concretarlo.

Se rodeó de colaboradores de muy alto nivel profesional como el Dr. Santiago Gorostiague y posteriormente el Dr. Jorge Hauri (cirujanos pediátricos), Dr. Ballina y Dr. Carlos A. Torres (cardiólogos), Dr. Ziziensky (neurólogo), Dr. Guillermo Raglia (neurocirujano), Dr. Brusés y Dr. Francisco Unchalo (radiólogos), Dr. Pawlov (anatomopatólogo), Dr. Gregorio Stern (endoscopista), Dr. Oscar Vidal (hematólogo), Dr. A. Actis Dato y Dr. Sarrallet (bioquímicos), Dr. Castellano (cirujano de tórax).

– *¿Qué pensaba de las acciones de promoción y prevención de la salud?*

Era un adelantado, recuerdo, por ejemplo, que fue un ferviente defensor de la lactancia materna y, convencido de sus propiedades inmunológicas, con el apoyo de medios gráficos, promovió la donación de leche materna y creó un pequeño banco de leche humana, con la que pudo controlar una epidemia de enterocolitis necrotizante a *Escherichia Coli* EPI en la década del 70.

– *Patricia hace un instante nos contabas que es increíble y emocionante para vos, en tu función de Profesora Adjunta de la Cátedra de Pediatría A y de Jefa del Servicio de Docencia e Investigación de nuestro querido Ludovica, recordar a tu padre desde los lugares de su historia. ¿Cuál fue el aporte del Profesor Climent a la docencia de Grado y Postgrado en Pediatría?*

Mi padre consideraba que la actividad asistencial y la docente eran inseparables. La capacitación la canalizó a través de la Cátedra de Medi-

cina Infantil de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y como Encargado de Docencia e investigación.

Transcurrió por todos los escalones docentes.

Fue Docente Autorizado de la Cátedra de Medicina Infantil de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP en 1955, Jefe de Trabajos Prácticos desde 1957 a 1963, Profesor Titular de la Cátedra de Puericultura de la Escuela de Obstetricia de la UNLP desde 1956 a 1963, Profesor Adjunto de la Cátedra de Pediatría por concurso en 1963, llegando a Profesor Titular en 1967. Posteriormente fue designado Profesor Emérito de Pediatría por la UNLP.

– ¿En qué año creó las Residencias Médicas de Pediatría y de Neonatología?

La Docencia y el aprendizaje en Servicio lo imaginó a través del sistema de Residencias Médicas. Primero la de Pediatría, que se inició, por su intensa y perseverante gestión en el año 1968, y posteriormente se acrecentó con la creación de la Residencia de Neonatología en 1974. Luego incorporó la rotación de residentes de Pediatría y visitantes de ciudades del interior que pensarían instalar Servicios de Neonatología similares en el país.

Su mayor orgullo fueron sus discípulos que continuaron con su obra y organizaron Centros de Terapia Neonatal en diferentes puntos del país y en el exterior, de los que aquilataba sus cartas como un tesoro.

– ¿Qué opinaba de los trabajos y de las publicaciones científicas?

Consideraba que el médico tenía la obligación de hacer trabajos sobre su actividad asistencial y de Investigación, como una herramienta de documentación, reflexión y actualización de sus conocimientos.

Toda su actividad profesional, se cimentó sobre tres pilares: Asistencia, Docencia e Investigación. La actualización permanente con publicaciones internacionales científicas y sus cualidades de lector incansable y apasionado le permitieron estar siempre en la vanguardia, incorporando tratamientos de avanzada.

Algunos de sus trabajos y publicaciones

En 1953 presentó sus primeros trabajos ante la Sociedad Argentina de Pediatría, y recibió el Premio “Schweitzer” en 1955, por su trabajo “Nefrosis lipoidea, experiencia clínica” y el Premio “25 aniversario de la SAP” en 1962 por el trabajo “Megaduodeno congénito en el RN”.

En 1954 comenzó a dictar conferencias en Cursos de Perfeccionamiento Universitario de Post-Graduados sobre “Comas en Pediatría”, “El vómito quirúrgico”. En 1955, “Hibernación de un niño con Tétanos grave, curado”, “Formas malignas de gripe tratadas con hibernación artificial”, en el año 1955.

1961 “Íleo del recién nacido”, “Enterocolitis necrotizante”, “Atresia de intestino en el RN aporte de un caso curado”, “Neumocistis carinii en el RN”. En 1963 “Neuroblastoma en el RN” y “La infección pulmonar en el RN: Valoración estadística”, en 1964 “Distrofia torácico-asfíxica del lactante”.

Desde 1963 comunicó trabajos ante sociedades científicas sobre “La ayuda mecánica respiratoria en las neumonías agudas del lactante”, “Dosaje de oxígeno en sangre capilar para valorar la insuficiencia respiratoria en el RN”, “Afibrinogenemia en el recién nacido”, “Complicaciones cerebrales de los trastornos electrolíticos en la hipernatremia”, “Transposición de los grandes vasos”, “Atresia de la arteria pulmonar en el lactante”, “Membrana hialina”, “Listeria monocitógena en el RN”.

– Patricia, contanos acerca de los viajes de perfeccionamiento de tu padre, y la relación de ellos con sus preocupaciones por la salud neonatal.

En 1960 obtuvo una Beca de un año por concurso de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) para el estudio de las Neumopatías del Lactante permaneciendo un año en Europa rotando por la Clínica Gaslini de Génova y visitando Clínicas Pediátricas Universitarias en Ginebra, Zurich, Basilea, Viena, Zagreb, París y Barcelona, de las que recopiló los lineamientos de organización para el Servicio de Recién Nacidos y los programas de postgrado para la formación pediátrica y neonatológica. Permaneció 11 largos meses en

Europa, que le significaron un gran avance en su formación profesional.

La altísima mortalidad neonatal en la década del cincuenta le generó una gran preocupación y en 1963 comenzó su actividad como Investigador Asociado de la CIC, en Investigación Clínica sobre “Patología del Pulmón del Recién Nacido” en la Sala V del Hospital de Niños de La Plata, bajo la dirección del Dr. Isnardi. Becado por la CIC para estudiar los Centros de Neonatología con los doctores Silverman en Nueva York, Clement Smith en Boston, Usher en Montreal y Álvarez de los Cobos en México.

A su regreso planificó una Unidad de Investigación Clínica con laboratorio, equipos de ayuda de diagnóstico en forma funcional y en contacto con la parte asistencial. En el año 1966 el apoyo de la CIC y el aporte de la comunidad en forma anónima permitieron la creación del sector de Terapia Intensiva con el equipamiento necesario: sus primeras cuatro incubadoras, un respirador, aparato de rayos portátil y laboratorio en la Sala V de Lactantes.

Participación en Cursos, Congresos y Jornadas

En 1965 realizó sus primeros Cursos sobre “El pulmón neonatal”, “Fisiología respiratoria del RN”, “Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido”, “Alteraciones hidroelectrolíticas y el equilibrio ácido base en el RN”, “Radiología del pulmón del RN y malformaciones del aparato digestivo del RN” y “Urgencias del RN Prematuro”.

Disertó en Congresos y Jornadas Pediátricas Nacionales e Internacionales sobre: “Grandes Síndromes del recién nacido y el prematuro”(1963) , “El pulmón normal y patológico del RN” (1964), “Correlación clínico radiológica del pulmón patológico del RN”(1964), “Fisiología del Prematuro”(1965), “Alteraciones del medio interno en las bronconeumopatías agudas”(1966), “Fisiopatología del distress respiratorio idiopático”(1967), “La infección pulmonar en el RN”, “Ventiloterapia en el RN”(1968), “El riñón del recién nacido”(1968), “El examen neurológico del RN”(1968), “Terapia Intensiva en el RN”(1969), “Terapéutica fisiopatológica en las enfermedades pulmonares”(1969), “La infección bacteria-

na inespecífica en el RN”(1970), “Neumopatías del RN”(1970).

Dictó y organizó innumerables Cursos sobre la atención del Recién Nacido y la Terapia Intensiva Neonatal, “Nefrología Pediátrica” (1966), “Alteraciones hidroelectrolíticas y el equilibrio ácido-base en el RN, fisiopatología” (1967).

Reconocimientos

Recibió múltiples reconocimientos:

- ✓ “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de La Plata
- ✓ “Profesor Emérito” de la Cátedra de Pediatría de la FCM de la UNLP
- ✓ “Consultor en Neonatología del Hospital de Niños de La Plata”
- ✓ “Premio al Médico” del Colegio de médicos Distrito I
- ✓ “Maestro de la Medicina” del Colegio de Médicos en 2002
- ✓ El Servicio de Neonatología del Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata lleva su nombre

–Patricia, ¿cómo era tu padre en la vida cotidiana? ¿Tenía tiempo para percibir el mundo que lo rodeaba?

Para poder hacer una semblanza de su personalidad es necesario mencionar que fue un lector apasionado de literatura, historia, psicología, filosofía, política social y avances tecnológicos en todos los ámbitos. Al entrar en su escritorio siempre tenía una revista o un libro en sus manos, se escuchaba música clásica y se sentía el aroma de su pipa. Su biblioteca tenía todo tipo de literatura, no sólo médica.

Apasionado por la fotografía, amante de la música clásica, el ballet, la pintura y el arte en todas sus expresiones, fue un hombre con una formación íntegra que le permitió una visión social de la Medicina y la Neonatología que lo llevó a una dedicación completa a la actividad hospitalaria y docente tanto en el pregrado como en el postgrado.

En lo familiar, pudo disfrutar con su esposa y sus hijos los domingos en su casa frente al río, las vacaciones en el mar y los espectáculos artísticos del Teatro Argentino, transmitiendo su pasión por el Ballet a mi hermana y a mí, alen-

tándonos en esta faceta artística como bailarinas profesionales. Disfrutaba del “fútbol bien jugado”, como solía decir, y en su juventud llegó a jugar en la 3° del Club Estudiantes de La Plata. Los domingos nos solía llevar al hospital a ver la obra durante la construcción del Servicio de Neonatología y nos transmitió la pasión por la Medicina a sus cuatro hijos.

Toda su tarea asistencial la desarrolló en el Hospital Público, considerando que todos los niños, tienen el derecho a la salud y a la atención de máxima calidad, independientemente de su clase social, atendiendo en su Servicio de Neonatología del Hospital de Niños de La Plata con la misma dedicación y esfuerzo tanto a hijos de personalidades influyentes y poderosas de la época como a los niños de familias desprotegidas.

Siempre se definió con orgullo como un trabajador hospitalario.

En el ámbito médico fue un visionario y se adelantó a sus colegas, manteniéndose informado con publicaciones extranjeras que leía apasionadamente en inglés y francés (autodidacta), logrando estar a la vanguardia de los avances a nivel europeo y norteamericano y aplicándolos concienzudamente, otorgando al paciente hospitalario la máxima complejidad en la atención y los tratamientos más avanzados.

Fue un pionero social, respetando el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales del ser humano.

Lo avanzado que resultó para sus colegas por su actualización permanente e implementación de medidas terapéuticas innovadoras, le generó con los médicos de su generación dificultades y desencuentros; pero inspiró a una generación de jóvenes médicos que siguieron sus pasos y lograron continuar con sus ideales.

Incansable en el trabajo permanecía al lado del paciente crítico y estudiaba hasta resolver el caso más complejo a la par del médico que se iniciaba, manteniendo su capacidad de asombro hasta el último día del ejercicio de su profesión.

Su entusiasmo continuaba acompañando a las familias en la evolución después del alta y si el paciente fallecía realizaba la autopsia para llegar al diagnóstico y replantearse si hubiera habido

algún tratamiento posible para evitar la muerte de ese niño.

“Debemos aprender de nuestros errores para no repetirlos”, solía decir ante el fracaso y el deceso de un pacientito, no descansando hasta lograr desentrañar la fisiopatología de la enfermedad.

Investigador, docente, lector y autodidacta son palabras que ayudan a definir su personalidad.

Entregaba sus conocimientos sin egoísmo permitiendo a los jóvenes en formación disfrutar hasta la última gota de su saber.

Su sencillez y simpleza para vestirse, así como el trato personal sin formalidades hacían que fuera accesible en forma permanente para los estudiantes y padres, y solía ser confundido con personal no profesional. Disfrutaba confrontando sus experiencias e investigaciones en los Congresos de Pediatría y acompañaba sus presentaciones con diapositivas que fueron la documentación de sus vivencias.

Fue un hombre sencillo, honesto, muy sensible, generoso y solidario, tanto hacia los médicos y residentes en formación, como hacia otros profesionales del hospital: enfermeras, bioquímicos, radiólogos, bacteriólogas, y especialmente con los padres de los pacientes internados, habiendo llegado a comprar equipamientos o medicaciones con su magro sueldo hospitalario. Se lo recuerda entregando su piloto a la madre de un paciente para abrirla.

Su jubilación a los 60 años, durante la dictadura militar en 1977, el día de su cumpleaños, fue un duro golpe que le generó el “exilio” de su querido Servicio y el alejamiento de su actividad asistencial hospitalaria, a la que se dedicó por entero. No obstante, ello continuó su actividad en la Cátedra de Pediatría hasta los 65 años y sus nietos fueron su remanso.

Su mayor orgullo fueron sus discípulos que continuaron con su obra y organizaron Centros de Terapia Neonatal en diferentes puntos del país y en el exterior. Ordenaba sus cartas como un tesoro. Una de sus discípulas, la Profesora Dra. Herminia Itarte de Scasso, siendo Jefe del Servicio de Neonatología, en 1996 remodeló el Servicio de Neonatología y le impuso el nombre de mi padre, pudiendo disfrutar de ese memo-

rable y merecido reconocimiento.

Este pequeño y apasionado gran hombre se constituyó en uno de los pilares de la Neonatología de nuestro país por lo que es considerado actualmente Maestro de la Medicina y uno de los Padres de la Neonatología en la Argentina.

En sus últimos discursos sobre su vida hizo suyas las palabras de William Osler en el epílogo de su libro *Aequanimitas*; *“Lo que el porvenir me reserva yo no lo sé y vosotros tampoco. Tampoco me preocupa mayor cosa en tanto que lleve conmigo, como lo haré, la memoria del pasado que vosotros me habéis labrado, no hay nada en el mundo que pueda privarme de eso. He cometido, sí, equivocaciones, pero han sido de la cabeza y no del corazón”*.

***Prof. Dra. Patricia Ester Climent de Plaza**

Ex Jefa Servicio de Docencia e Investigación del Hospital Interzonal Especializado Sor María Ludovica
Profesora Cátedra A Pediatría. Facultad de Medicina.
Universidad Nacional de La Plata.

LUIS GARCÍA AZZARINI, “LUISITO”

PROF. DR. JUAN REICHENBACH, EN SU HOMENAJE



En marzo de 2002, el Prof. Dr. Luis García Azzarini fue designado para coordinar la Unidad Ejecutora de Programas Materno-Infantiles y Nutricionales y conducir la Dirección Nacional de Salud Materno Infanto-Juvenil de-

pendientes del Ministerio de Salud de la Nación.

Tuve el privilegio de secundarlo como Director de Planificación Estratégica y, primordialmente, de atesorar sus enseñanzas de humanidad, afecto y humor.

Quería que todos los niños de nuestro país recibieran su espíritu solidario, como lo habían hecho sus hijos de la mítica “Casa Cuna”, Hospital Noel Sbarra de La Plata, y sus millares de pacientes.

Tenía una concepción abarcativa de la salud infantil.

Empezaba por la verdulería del barrio, pasando por la peluquería, el Club de los sábados, el Concierto los domingos en el Teatro Argentino y el asado en la casa de mis padres, donde recordaba a su padre Domingo y a su madre Sara, incansables trabajadores en las localidades de Verónica, Ensenada y La Plata.

Luis nació en La Plata en 1937. Realizó una brillante carrera profesional, con todos los logros que las Academias requieren. Fue Doctor en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, Médico del Hospital de Niños Sor María Ludovica y del Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra donde realizó su carrera Profesional Hospitalaria a partir de 1975. En esta institución fue Jefe del Consultorio Externo, Director Asociado y luego Director Ejecutivo desde 1995 hasta 2002. En la Cátedra de Pediatría “A” realizó su generosa vocación docente y llegó a ocupar el cargo de Profesor Adjunto por Concurso.

Obtuvo múltiples premios y distinciones valio-

sas en el ámbito Científico Nacional. Fue Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial La Plata, ejerciendo los cargos de Vicepresidente y Presidente. Integró, además, la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría donde se desempeñó como Vicepresidente y donde recibió la distinción de Miembro Honorario Nacional de la SAP.

Luis es Ciudadano Ilustre de la Municipalidad de La Plata.

Si estuviera conmigo escribiendo su propio homenaje, me diría, sutilmente, que escriba lo importante, lo del alma, para dejar los títulos para otra ocasión.

Me contaría en su idioma apurado “coloquial y alegre”, mil y una anécdotas de sus visitas nocturnas y domiciliarias en Tolosa, donde le gustaba ser “el médico del barrio”, o cómo asociar comunidades a través de los títeres en Abasto, de la mano de Javier Villafañe, poeta, bohemio y titiritero amigo, al servicio de su salud infantil.

Quizás recordaría algún cantante de orquesta de pueblo en un baile de carnaval en Verónica, o los instrumentos del Museo Azzarini, de su tío Emilio, intelectual platense de los 60.

Con su mirada sagaz y pícara desnudaría los intereses ocultos de algún funcionario de provincia o la hipocresía de los falsos poderes.

Su agenda conocía de Museos pictóricos en Europa, tacos en Madrid, chorizos en el pueblo más anónimo de la pampa y plomeros de confianza.

Era un bohemio disimulado por la Academia. Un poeta de los niños. Un gestor y funcionario de la ética y la equidad. Padre ejemplar, presente. Marido enamorado de su compañera de “locuras”, Anina. Abuelo “fanático”.

Fue docente de quien escribe. Me embriagó de pediatría y de poesías. De amor a los niños. De ejemplos de humanidad. De reflexiones acerca de las verdaderas causas de la ausencia de sonrisas infantiles en nuestro país. Cuando viajába-

mos todas las mañanas a Capital Federal, al Ministerio de Salud de la Nación, me leía, en el viaje, a Benedetti, a Gelman, a Galeano, a Machado, a García Lorca. En uno de esos largos derroteros me prestó “La tierra incomparable” de Antonio Dal Masetto, donde se rescata a una abuela que desde la Argentina viaja a su lugar de origen en Italia, para reconocerse. En ese tiempo Luis viajó a Italia con su esposa, en misión oficial, y logró reencontrarse con los estigmas de su origen.

De sus logros Académicos abundan las revistas científicas.

Para él, lo más importante era la sonrisa de un niño sano, la serenidad de una familia que ha recuperado un hijo enfermo, el abrazo de amigo, una comunidad y un país de niños alegres.

De esa época es este relato que le regalé en el 2002 para recrear su humanidad y su espíritu.

Pequeño guión para Luisito

Ayer te vi.

Estabas chapoteando, infantil, entre las aguas desbordadas del Plata, justo en la esquina de tu casa, sumergida entre juncos y totoras de una nueva inundación.

Eras un niño inundado, como los que amaste.

En un paisaje de chapas y colores, de dalias de jardín, con aromas de ravioles solidarios de familias, domingos y de canzonetas pegadizas.

Tenías en tus ojos la clara transparencia de un obrero hecho hijo.

Por tu sangre circulaban las ansias de tus orígenes.

De justicia, amores y pasiones.

Fue por allí donde te intuí cerca.

Nos unía un pasado de poco, un futuro de a muchos y las manos endurecidas de padres con penas y esfuerzos.

Había que llorar, maestro, las derrotas cotidianas, las de las noches, las ausencias y las de las sirenas amenazantes.

Ponerles un ancho pecho y una mueca disimulada de miedo.

Un ejército inválido de niños hambrientos, pero sonrientes, nos obliga.

Un tiempo de valientes románticos, suicidas sociales y esfuerzos místicos, nos rodea.

Déjame, ahora, imaginar un día de sol y de triunfos. Las caras duras, inmóviles, de las mascaritas de este cambalache.

Un tango reo y rítmico, como tu energía.

Una alegría fresca y transparente, como tu mirada.

Un abrazo fuerte, como de amigo.

Una brisa frágil, como el futuro.

Nuevamente, me pierdo en el pasado.

Estás en una escalinata, de Facultad.

El edificio rígido y frío, como los restos de historias tristes que lo habitan.

– No se puede cambiar, Luis.

Es una fortaleza inexpugnable de la genealogía de la enfermedad.

– No nos pertenece, Luis.

Somos hijos del pueblo y el pueblo piensa, pero pena.

– No escuchaste. Latina, tu tozudez

Trémulo temblor el de este otoño.

Alada alegría la de tu alma.

Sincera convicción la de tu espíritu.

Empuñemos, entonces, la esperanza.

– Cuidate, Luis.

– Cuando la vida se milita, la alegría no se regala.

Es por aquí que te reencuentro.

Con tu puedo y con mi vamos, con las pequeñas derrotas,

con la imagen del origen y con las fantasías que nos alegran.

Para un amigo y maestro del alma, La Plata, navidad del 2002.

***Prof. Dr. Juan Reichenbach**

Doctor en Medicina.

Consultor en Pediatría.

Profesor Adjunto Cátedra Pediatría B Medicina de la UNLP.

Profesor Titular de la asignatura Salud del niño, niña y adolescente(SaNNA) Escuela de Medicina, UNMDP.

Docente de la Facultad de Medicina de UNICEN.

Docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER.

Ex Director Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación.

Autor de varios libros de Clínica Pediátrica y de Salud Pública.

REFLEXIONES SOBRE LA PEDIATRÍA AMBULATORIA



DRA. FANNY BREITMAN*

Sumario

Una visión integral acerca de la salud infantil con una perspectiva de derechos, de equidad e inclusión por una referente de la pediatría argentina. La reivindicación de la clínica, del consultorio, del arte de la pediatría.

¿Cómo se titula mi presentación? Pensé un subtítulo: ¿Por qué otro Congreso de Pediatría General Ambulatoria?

Porque hay una especificidad propia de la pediatría ambulatoria.

Nuestro objeto de trabajo es la salud, dirigida a la población, no sólo la que está enferma. Con eje en la promoción y la prevención y en la detección temprana de problemas.

La pediatría ambulatoria está integrada, involucrada como componente imprescindible en la APS.

La internación es una irrupción fortuita, indeseable, a veces evitable, en la vida de niños/as o adolescente quienes en su dimensión real y cotidiana requieren nuestra labor en consultorio. Evitar internaciones, ahorra costo emocional para el niño y su familia, ahorra riesgo de enfermedades intrahospitalarias y ahorra costo económico para los individuos para el estado y para la sociedad.

El sistema en el que estamos inmersos aplaude o remunera a la medicina reparadora y subvalora la promoción, la prevención, la atención de enfermedades comunes y al primer nivel de atención vistos de segunda categoría o que exigen menos conocimientos o menos sustento científico. Pero es más preocupante que el inconsciente colectivo que nos incluye identifica el accionar pediá-

trico sobre el paciente internado con lo heroico y brillante rápidamente asociable a “salvar vidas”. En igual perspectiva la tarea cotidiana en consultorios más o menos grises luce banal, pequeña, simple, intrascendente.

Es igualmente asimétrico el concepto sobre la actividad de los especialistas. Sin ser peyorativo, la especialidad, por su condición de tal, da una visión en tubo, profunda pero angosta de una situación. Le cabe al pediatra general la visión imprescindible abarcativa, de conjunto, de amplio espectro y de alguna forma más realista de la salud y enfermedad.

Ha dicho Virginia López Casariego en PEDAMB: No se trata de competir o generar una disputa entre sectores médicos. Se trata de identificar y complementar ciertas destrezas, saberes y haceres específicos que son propios de la pediatría ambulatoria.

QUÉ FUNCIONES

Somos en primera instancia médicos, personajes cuya palabra está categorizada socialmente. Con esta condición primigenia funcionamos, en asociación con otros efectores de salud, como guía, apoyo y ayuda disponible para seres dependientes, para sus cuidadores y su familia y su familia ampliada, miembros de una cultura y de una sociedad que todavía dista de ser justa o equitativa.

Es difícil visualizar la complejidad que requiere la mirada y la acción centrada en la salud.

La actividad de consultorio requiere gran habilidad y destreza para sintetizar información biológica y psicosocial, para comprender y hacerse comprender y trabajar con otras disciplinas. Voy

a mencionar aspectos anecdóticos para ilustrar lo que trato de decir.

¿De qué hablamos en CONCRETO cuando hablamos de promoción de la salud?

- Hablamos de orientar conductas y hábitos. Menciono ejemplos sin ningún orden jerárquico:

- ✓ Hablamos de la salud sexual y reproductiva con implicancias no sólo en embarazos no programados adolescente y de ETS (con secuelas posibles de esterilidad o muerte) sino de promoción de sexualidad gozosa
- ✓ Hablamos de hábitos saludables de alimentación. Sus implicancias a corto y mediano plazo son obvias
- ✓ Hablamos de incentivar la lectura demostradamente útil para el desarrollo intelectual de niños pequeños
- ✓ Hablamos de evitación de tabaquismo: 1ª causa de EPOC y enfermedades cardiovasculares
- ✓ Hablamos de estimular vínculos intrafamiliares ricos
- ✓ Hablamos de promover inserción social
- ✓ Hablamos del respeto a modalidades de culturas y crianzas con impacto en la escolarización de hijos de migrantes internos y externos.
- ✓ Hablamos de sugerencias estimulantes del desarrollo
- ✓ Hablamos de promoción de la lactancia materna y sin entrar en fundamentalismos grotescos, con demostrada protección para infecciones intestinales y respiratorias, que encabezan la morbilidad en el 1º año de vida

¿De qué hablamos en CONCRETO cuando hablamos de prevención? Hablamos de utilizar herramientas para:

- ✓ Prevención de obesidad: pandemia causa de severa morbilidad y que se pronostica será la 1ª causa de trasplantes hepáticos en niños en un par de décadas más
- ✓ Prevención de enfermedad cardiovascular: 1ª causa de muerte en adultos
- ✓ Prevención de enfermedad respiratoria como BQL o crisis asmáticas con alta carga de internaciones y secuelas
- ✓ Prevención de problemas psicológicos y psicosociales relacionados con marginali-

dad social, delito y violencia doméstica

- ✓ Prevención de adicciones estando alerta a conductas adictivas de nuestros pacientes desde la Coca Cola a Play Station
- ✓ Prevención de problemas de desarrollo de altísima prevalencia sobre todo en poblaciones de bajos recursos. Estos problemas de desarrollo generan costo emocional, económico, de sobre prestaciones pero además perpetúa la cercenación de oportunidades de estudio y laborales
- ✓ Prevención de embarazo adolescente no programado causa de muerte materna, de bebés prematuros y BPEG y 1ª causa de morbilidad neonatal
- ✓ Prevención de accidentes, 1ª causa de muerte en preescolares
- ✓ Prevención de osteoporosis con el adecuado suministro de vitamina D y Ca y actividad física particularmente en la adolescencia
- ✓ Y por supuesto evitación de enfermedades inmunoprevenibles con el manejo apropiado de vacunas y alerta de las oportunidades perdidas
- ✓ Hablamos de prevenir muerte súbita indicando la posición demostradamente apropiada para dormir, boca arriba y no otras

Es prevención evitar el rótulo invalidante de enfermos a pacientes que tienen variantes de la normalidad, variantes de la normalidad en:

- ✓ el crecimiento (y no estudiar petisos demás)
- ✓ en el ritmo evacuatorio (y no derivar lactantes amamantados que evacúan cada semana)
- ✓ en la evolución del lenguaje (y no convertir las dislalias filológicas en motivos de interconsultas que además nunca habrá turno para concretar)
- ✓ variantes evolutivas de la escritura y no considerar que una persona de 7 años tiene un trastorno de aprendizaje porque invierte sílabas al escribir o no etiquetar con títulos “oposicionista desafiante” “ansiedad de separación” ADDH, descontextuado de su edad o de su estilo de comportamiento eventualmente inquieto, curioso, extrovertido

El Diagnóstico de salud es más difícil que el de

enfermedad. Se requiere un gran conocimiento de la normalidad y sus variantes. Crecimiento, maduración, desarrollo, familia “normal” ¡Normalidad!, término complejo si los hay!!!

¿De qué hablamos en CONCRETO cuando hablamos de detectar problemas oportunamente? Doy ejemplos de nuevo en orden no jerárquico.

- ✓ La sensibilidad de las pesquisas neonatales nunca es del 100 %. Sigue siendo imprescindible la mirada adecuada del pediatra para diagnosticar un hipotiroidismo congénito. O detectar una hipoacusia ya que además no son todas congénitas
- ✓ Tampoco las ecografías de cadera son el patrón de oro para la enfermedad luxante de cadera
- ✓ Detectar estos y otros problemas evita implicancias serias futuras en la funcionalidad, la calidad de vida y el trabajo
- ✓ Los maestros y los pediatras somos casi los únicos que podemos detectar oportunamente perturbaciones vinculares intra-familiares o sociales y maltrato o abuso sexual
- ✓ Detectar oportunamente al asesino silencioso: la Hipertensión. Tomar la presión. Simple, ¿verdad? Pero requiere técnica precisa no fácil de aplicar correctamente tanto desde el operador como del instrumento y de tener resultados confiables.

Los pacientes no van al consultorio del hematólogo o del neurocirujano o del infectólogo o del oftalmólogo o del gastroenterólogo o cualquier otro ólogo diciendo: “mi hijo tiene leucemia o un tumor cerebral o SIDA o catarata o colon irritable”. Alguien, y esos somos nosotros, tiene que advertir la clínica para una derivación oportuna y a quién corresponde, sin volvernos derivadores seriales.

¿De qué hablamos en CONCRETO cuando hablamos de curación de enfermedades?

- ✓ Somos, se dice, los que nos ocupamos de enfermedades banales. No hay enfermedades banales. Siempre es un motivo de stress y preocupación no sólo para los pacientes. ¡Pensemos un instante en un niño pequeño febril sin foco! O en las mioclonías del sueño de un lactante. O en alguien con tos severa o prolongada

- ✓ Estamos para suministrar un tratamiento oportuno y sensato basado en conocimientos, dar una explicación oportuna, una anticipación evolutiva
- ✓ Sé que alivia la inseguridad decir: “venga mañana a control”. Pero hay que decir: “esta gripecita, esta diarrea puede durar varios días o tantos días o probablemente va a ocurrir esto o aquello”. Así puede bajar el nivel de ansiedad y de re consultas por el mismo problema y gastos de dinero que el paciente puede necesitar para comer
- ✓ Nos compete el diagnóstico preciso de una otitis. Si somos honestos sabemos que no es fácil. Consecuencia: ATB innecesarios, resistencia antibiótica, sordera, colesteatoma
- ✓ Somos los primeros de la fila para interpretar que esta manchita es una petequia y no una picadura de pulga. O viceversa. Consecuencias obvias
- ✓ Somos los que indicamos qué comer o qué tomar durante una diarrea y evitar desnutrición o deshidratación iatrogénica
- ✓ Somos los que tenemos que taparnos los oídos pero sobre todo el cerebro para no ceder ante el canto de sirenas de malintencionada propaganda de los poderes mágicos de ciertos medicamentos, bebidas y alimentos
- ✓ Somos los que tenemos que diferenciar una enuresis no complicada de incontinencia urinaria: las causas y consecuencias son abismalmente diferentes

¿De qué hablamos en CONCRETO cuando hablamos de atención de pacientes crónicos y rehabilitación?

El progreso del tratamiento y la supervivencia de niños, niñas y adolescentes externados de las Terapias intensivas, de los portadores de trastornos polimalformativos o del desarrollo, genéticos o no, y de enfermedades crónicas sistémicas, ha generado una población de altos requerimientos de atención ambulatoria. Son nuevos huérfanos. No son atendidos en su integralidad por los especialistas y el seguimiento por pediatras generales es irregular, segmentario, expulsivo. Son seres humanos sujetos de derecho y nos compete el enorme desafío de trabajar sobre sus aspectos sanos.

TENEMOS UNA TÉCNICA DE TRABAJO

Solamente con empatía se puede establecer un vínculo médico-paciente y lograr con la palabra efectos que han sido demostrados.

Significa ser solidarios con el sufrimiento real o potencial de otro ser.

Significa pensar en el otro.

Significa pensar cómo hablamos cuando decimos livianamente “Tiene solamente un síncope”: para el lenguaje técnico es un desmayo mientras que para el público es sinónimo de un ataque cardíaco.

Significa no sólo pesar y medir sino consignarlo en las desérticas libretas sanitarias y cuando es necesario derivar a otro colega escribir un resumen legible, que reflejen la experiencia vivida, los eventos ocurridos, los exámenes complementarios efectuados.

Requiere interés por entender el relato de los pacientes filtrados por su entendimiento, sus experiencias, preconceptos y temores.

Requiere reconocer que la persona es un entramado bio-psíquico-social y sus avatares multicausales.

Requiere desprenderse de prejuicios y aceptar singularidades culturales, sean de poblaciones extranjeras, de una villa o de Puerto Madero.

La dignidad personal y los complejos laberintos del psiquismo no son tributarios de un grupo social.

Sin motivación y, aunque parezca cursi, sin amor por lo que hacemos no se puede.

La semiología ancestral: anamnesis y examen físico minuciosos, es la herramienta suprema de trabajo. Incluye observar lo que no se dice con palabras y deslindar lo encubierto de lo maniifiesto.

En tanto médicos tenemos que tolerar lo probabilístico, las incertidumbres, el miedo a equivocarnos.

Tenemos que aceptar que no somos dueños de la verdad revelada, que hay muchas verdades y se puede decir: no sé.

Cada encuentro con un paciente es una oportunidad de intervención, de ayuda y de ejemplo ético. Para algunos individuos será la única oportunidad de sentirse personas.

Somos una mezcla variopinta de actores (en el sentido de acción y de salir a escena) y detectives.

DEBEMOS TENER CONOCIMIENTOS CIENTÍ-

FICOS. Para cumplimentar las funciones que demanda la pediatría ambulatoria con honestidad se requiere estudio, serio y riguroso, como para otras ramas de la medicina.

Dice F. Escardó en Moral para médicos: “*la actualización del conocimiento no es un problema intelectual sino ético*”.

Me baso en el Dr. Agrest que dice que si bien hay artesanía en el accionar profesional, la pérdida del rigor científico es tan peligroso como la pérdida de la visión humana del paciente. Creo que el aprendizaje debe ser permanente y nuestra educación continua es responsabilidad individual e institucional.

La explosión de información que nos inunda es inabordable. El aprendizaje de hoy consiste en adquirir criterio para seleccionar lo útil de lo superfluo. Aprender a aprender. Creo en la formación de grupos aliados por comunión de intereses, categorizando la colaboración en desmedro de la competencia, lo cual además enriquece a cada uno con el saber del otro. La comunicación virtual es una oportunidad de excelencia como se puede experimentar en la lista de discusión como es PEDAMB.

La realidad: la educación continua está a la deriva salvo por la oferta de sociedades científicas y la actividad en algunos hospitales. Las oportunidades de inserción hospitalaria son escasas por motivos organizacionales y económicos. Las obras sociales y los sistemas de medicina prepaga no se ocupan de la formación de sus prestadores.

Hay componentes del sistema cultural que incitan a perder el compromiso y la auto superación. Existe una palabra dramática que me perturba y que ha surgido en nuestra sociedad hace unos años: zafar, y las palabras expresan lo que se piensa.

RECONOZCAMOS LA TRASCENDENCIA.

Con un pantallazo somero, y todo lo pendiente por decir, es hasta cierto punto absurdo tratar de justificar la seriedad, la responsabilidad personal y social, en síntesis, la complejidad, de la labor del pediatra ambulatorio.

No desconozco LOS OBSTÁCULOS que generan malestar y descontento.

Existen obstáculos vinculados a la práctica individual: imposibilidad de satisfacer pacientes que demandan utilizar tecnología o tienen exigencias infundadas por la facilidad de acceso a información de fuentes dudosas.

Encuentro un empobrecimiento del lenguaje cotidiano generando más barreras de entendimiento. Existen obstáculos institucionales y del sistema en general. Nosotros somos también ciudadanos de un país no sencillo, de futuro incierto, de reglas de juego inestables en el que el sistema de salud queda incluido.

Somos depositarios de falta de reconocimiento de empleadores privados o del estado que se traduce en poco tiempo para atender, poca paga, infraestructura de mala calidad y una representatividad gremial endeble. Debemos convivir con la impotencia para resolver injusticias sociales y el acceso a la salud inequitativo. ¿HAY CAMINOS?

Hay caminos...todavía de ripio pero están trazados e inclusive algunos asfaltados. Voy a citar nuevamente el texto que circuló por PEDAMB de la Dra. Virginia López Casariego: *“La posibilidad de mejorar nuestras condiciones de trabajo es indisociable de las condiciones de vida y salud de lxs chicxs y familias que atendemos. Y también, de las capacidades que demostramos podemos desempeñar nuestro rol en equipos interdisciplinarios y espacios intersectoriales”*.

A diferencia de hace unos años, la pediatría ambulatoria ha logrado respetabilidad académica. Hay para Pediatría Ambulatoria Sociedades Científicas, Comités, libros, revistas científicas específicas, profesionales especializados.

Hay en nuestro país facultades de Medicina que presentan una currícula innovada con el acento en la formación de Atención Primaria de la Salud. Tengo el honor y la alegría de ser docente en una de ellas: la Unlam. Los programas de residencia de pediatría, lentamente, pero es-

tán cambiando exigiendo una carga horaria más importante en Pediatría Ambulatoria. Hubo una residencia efímera en Pediatría ambulatoria que podría volver.

Hubo hace años entre bicicleteada y bicicleteada por Agronomía una iniciativa visionaria del Dr. Gregorio Rowenstein (Gary para los amigos) junto al Dr. Abel Monk y al Dr. Hugo Sverdloff de hacer un Congreso de Pediatría Ambulatoria. Fue el 1º y hoy transitamos la versión corregida y aumentada del 6º Congreso de Pediatría General Ambulatoria. La palabra general no surgió por casualidad. Los sucesivos Comités de Pediatría Ambulatoria quisieron remarcar el carácter abarcativo de este trabajo empezando por la gestión del Dr. Emilio Boggiano como secretario.

Debemos un fuerte reconocimiento a quiénes dieron el puntapié inicial. En aras del progreso de estas iniciativas y a transformar frustración en producción hay que dar rienda suelta a la creatividad, reinventar estrategias, huir de la cultura del “zafar”, categorizar nuestra función, defender nuestros derechos como trabajadores y trabajar por un sistema de salud articulado, equitativo y que permée la estructura del estado independientemente de los gobiernos circunstanciales-

***Dra. Fanny Breitman**

Ex médica Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan. Ex Médica Hospital de Niños R.M. Gutiérrez de CABA. Miembro de SAP. Miembro de PEDAMB. Prof. de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza.

EL PEDIATRA Y LA LACTANCIA MATERNA



DR. GUSTAVO H. SAGER*

Introducción

La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. El término procede del griego paidos (niño) e iatrea (curación) pero su contenido es mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños, ya que la pediatría estudia tanto al niño sano como al enfermo. Desde el nacimiento o antes y hasta el final de la adolescencia, es decir: “Hasta los 54 años...”

El o la pediatra es la persona cuidadora de la salud y asesora en todas las cuestiones referidas a la crianza. El título de especialista dice: Especialista en Pediatría y Puericultura (no se olviden).

Ser pediatra implica asumir frente a la sociedad, la responsabilidad de abogar por el bienestar integral de los niños y sus familias, acompañando su crecimiento, interviniendo ante la presencia de enfermedades.

“Tenemos labores que cumplir cerca de las familias argentinas, repitiendo una y otra vez los gestos esenciales de nuestra profesión: ayudar, curar tal vez...” Prof. Dr. Carlos Gianantonio

El Dr. Noel Sbarra decía: *“El que sólo pediatría sabe, ni pediatría sabe”*.

Para ser pediatra: se debe saber historia, literatura, sociología, psicología, arte, ecología y pediatría.

La lactancia

Nuestro objetivo será lograr una lactancia satisfactoria, con disfrute. La lactancia, antes que un acto alimentario, es un acto de amor.

Un proverbio chino dice: *“somos lo que come-*

mos” y esto repercute en el tipo de vida y salud que se tenga. Cuando alimentamos a un niño con leche humana no sólo damos nutrientes: damos sabores (palatividad), genoma, la sabiduría de la armonía y la adaptabilidad a la ecología ambiental que necesita. Y si es directamente con el pecho además damos calor, movimiento, intimidad, palabras y caricias, dando sentido a la vida y autoestima, a través del amor de su mamá.

PARA AYUDAR NO NOS FORMA LA FACULTAD, NOS FORMA LA VIDA.

¿Qué debemos enseñar?

- ✓ Las madres tienen dos pechos para tener mellizos: Son capaces de producir para dos niños en forma Normal 1500 cc. de leche por día, 750 cc. para cada uno. La madre de un solo hijo produce 750 cc. por día y mantiene esta producción hasta el destete.
- ✓ SU LECHE SIEMPRE ES BUENA

Cada vez que los niños se prenden al pecho toman primero una solución (químicamente hablando), la primera Leche de 450 cal/litro a 560 cal/litro es rica en agua, lactosa, células vivas e inmunobiológicos. Luego el niño recibe una suspensión compuesta en su mayoría por las micelas de caseína y el calcio y por último si no cambia de pecho aparece una emulsión con cinco veces más grasa que la leche del comienzo, que al saturar las papilas gustativas de la lengua con grasa da la sensación de saciedad por lo que el niño queda “mamado”. La leche final tiene aproximadamente 714 cal/litro. En promedio de las tres leches, la leche materna aporta 640 cal/litro.

Por trabajos científicos sabemos hoy que la

lactancia tiene efecto: dosis- respuesta, es decir, cuanto más leche humana tome el niño mejor será su composición corporal y su salud.

La leche materna tiene en su composición 4000 glóbulos blancos vivos por cada centímetro de leche, la mayoría de estos macrófagos que como el pac-man se comen todos los virus, bacterias y parásitos que pueden estar en la leche y además los linfocitos que son capases de producir anticuerpos contra todas las enfermedades. La leche de vaca o la fórmula no tiene ninguna de estas dos cosas.

Debe enseñarse a las madres y a los pediatras que la leche materna se vacía del estómago del niño el 50% de lo que tomó en media hora y la otra mitad en dos horas a dos horas y media por lo que un niño que pide nuevamente el pecho a la media hora no es que se quedó con hambre sino que volvió a tener hambre.

PORTEAR Y ESTAR ATENTOS: Confirmar que los padres saben reconocer y responder a las señales tempranas del recién nacido: movimientos de succión, sonidos de succión, llevarse las manos a la boca, movimientos oculares rápidos, sonidos de llamada, estar molesto, no el llanto.

Hay que enseñar a las madres y al pediatra a verificar que el niño está tomando bien, que se prende bien al pecho y que exista transferencia adecuada de leche hacia el niño. Para controlar que el niño haya tomado suficiente leche se controlará luego de la bajada de la leche:

BUENA PRENDIDA, BOCA DE PESCADO



- ✓ DEGLUCIÓN AUDIBLE
- ✓ ERUCTO
- ✓ REGURGITACIÓN
- ✓ PIS
- ✓ CACA

Debe enseñarse al profesional y a las madres la técnica correcta de la extracción manual o mecánica de leche.

El pediatra debe saber que la teta no es un envase, es una glándula, no junta leche, la produce o no la produce. **CASI SIEMPRE LA PRODUCE**, a menos que se haga todo lo contrario a lo que se debe hacer. No sirve decir: voy a dejar que se junte. No se junta, salvo en una pequeña proporción, cuanto más rápido se vacía, más rápidamente se llena. Solo al quedar muy llena de leche se inhibe ligeramente su producción ¿Han visto alguna vez una teta explotar?

Luego del mes de vida en una lactancia que funciona perfectamente las madres comienzan a producir de otra forma, más automáticamente, cuando la madre percibe que su niño está por despertarse o va a pedir el pecho comienza a producir leche aceleradamente y justo cuando el niño hace los primeros gestos de hambre o sed, se comienzan a percibir los pinchazos de bajada de la leche (ocitocina). A partir de este tiempo, solamente las madres sentirán que sus pechos están turgentes a la mañana, cuando se despierta. El resto del día tendrá los pechos blandos y felices esperando ser agasajados por el hijo.

El biberón es una Prótesis (frase de mi Maestra la Dra. Marilú Ageitos). Marilú es una persona hermosa, primera presidenta mujer de la Sociedad Argentina de Pediatría, ha defendido siempre la lactancia y la vida, es madre y abuela, dijo *“usar una prótesis no es malo, si uno no puede caminar usará una muleta, o si no ve bien, los anteojos”*, la sociedad de hoy ha convertido a la mamadera en un ícono, en un tótem, en algo imprescindible y no lo es, por eso regalan esa monstruosa mamadera gigante llena de porquerías a las recién paridas, incluso algunos políticos las han regalado. Creo que deben existir las mamaderas y ser bellas, sin ftalatos, limpias para la gente que lo necesita, no que la den innecesariamente, porque el niño no se puede poner al pecho y porque no hay nadie que tenga los conocimientos y la paciencia necesaria para ayudar a la madre.

El biberón tiene tres problemas:

- ✓ Primero: adentro ponen leche de fórmula: leche muerta, uniforme, costosa, de feo gusto y olor, fabricada por una vaca para su hijo el ternero, animal forrado de cuero y cornudo que tiene cuatro estómagos y que con sus gases destruye la capa de ozono.
- ✓ Segundo: todo lo que se da con él de AFUERA se deja de producir de ADENTRO, compite con la teta NO LA COMPLEMENTA. Las madres son capaces en forma natural de producir leche para mellizos por eso tienen DOS TETAS, es decir que toda madre tiene el DOBLE de pechos de los que necesita un hijo único. Cuando le da biberón comienza poco a poco a producir para 3/4 de hijo, medio hijo, etc.
- ✓ Tercero: perjudica en su forma de succionar, produciendo una extracción menor de leche y DOLOR al cerrarle su boca y enseñarle a prenderse sobre el pezón, no sobre el complejoaréola y pezón. Poco a poco, el niño que recibe pecho y complemento en mamadera cada vez se vuelven menos predispuestos a tomar el pecho, los hacemos pasivos receptores y no activos actores en la relación de alimentación-amor.

Para estos casos hay que consultar en consultorios de lactancia, en maternidades que les den contención y solución, con los bancos de leche o con grupos de apoyo donde verifiquen la buena técnica de amamantamiento y que el niño realmente tome bien. De ser necesario, enseñar también otros MODOS DE ALIMENTACIÓN CON LECHE DE MADRE que no sean el biberón porque puede producir igual que el chupete lo que se llama confusión de pezón. Los métodos son:

- ✓ EL VASITO
- ✓ EL DEDO SONDA
- ✓ RELACTACIÓN CON SONDA

El profesional intervendrá o derivará los problemas del curso del amamantamiento. No se prende, no tengo leche, me duele cuando toma, toma muy seguido, llora mucho, no aumentó de peso, grietas, ectasia de conductos, mastitis.

Los pediatras y los trabajadores del equipo de salud no somos un colectivo uniforme, como no

lo son tampoco las madres, hay que considerar en forma individual cada historia personal y familiar, solamente así con empatía, conocimientos y ganas de ayudar se puede tratar de hacerlo.

CADA PROBLEMÁTICA DE LACTANCIA TIENE QUE RECIBIR UN TRATO INTEGRAL. NO BASTA CON UN ANTIBIÓTICO O UNA CREMITA.

¿Alguna vez el pediatra al terminar su ajetreado día de consulta se sienta a reflexionar sobre su ejercicio profesional? ¿No le extraña que la mitad de sus pacientes lactantes estén tomando fórmula a los tres meses, que la mitad de los mismos estén tomando omeprazol por presunta enfermedad por reflujo gastro-esofágico? ¿Que un tercio de sus pacientes este tomando leches con aminoácidos por APLV? ¿Estas cifras no le estarán diciendo que sus pacientes están mal asesorados? ¿Que las lactancias maternas están poco sostenidas por su gestión profesional? ¿Que no ha derivado a tiempo a un equipo que podría haber intervenido a tiempo y salvado el curso del amamantamiento exclusivo? Supongo que pensará “soy exitoso”, mis pacientes me quieren, soy un buen médico porque mis pacientes crecen sanos. ¿Crecen sanos?, ¿hacia dónde? ¿Hacia una adultez con enfermedades autoinmunes, con síndrome metabólico, diabetes, cáncer, hipertensión, ACV, hipercolesterolemias y coronariopatías?

Recuerden lo que dijo Florencio Escardó: el niño es el padre del hombre y la alimentación del niño tiene que ver con sus células, con su epigenética, con su microbiota, altera el ecosistema donde el niño se cría y tiene sus consecuencias: adultos enfermos con enfermedades crónicas, degenerativas y discapacitantes.

¿Cómo saber si tu pediatra apoya (de verdad) o no la lactancia materna?

- ✓ Comienza alabando los “beneficios de la lactancia materna”, se declara “muy pro-lactancia”, y sigue con largas e imaginarias listas de “peros” y considera a los sucedáneos exentos de riesgos. Se refiere a la lactancia materna únicamente como alimento (“leche materna”).
- ✓ A partir de cierta edad “no alimenta” o “se convierte en agua”. Se atreve a contarle a la madre lo que su hijo siente hacia ella: “te usa de chupete”, “te quiere

manipular"... Y el supuesto daño que la madre le hace a su hijo: "lo estás haciendo muy dependiente", "lo estás malcriando", "tendrá carencias de nutrientes".

- ✓ Cree que la lactancia materna no se integra en una vida normal.
- ✓ Considera inexistente la compatibilidad de la lactancia materna con el trabajo, la medicación y la internación del niño.
- ✓ Presenta grandes prejuicios ante la lactancia materna a demanda (especialmente la nocturna) y el colecho.
- ✓ Sus indicaciones sobre incorporación de la alimentación complementaria son incorrectas ("a los 4 meses..."), la lactancia materna la que pasa a ser "complementaria".
- ✓ Su principal fuente de información son falsos mitos, su sesgada experiencia personal y la industria de sucedáneos de leche materna.
- ✓ En su consultorio hay publicidad de la industria de sucedáneos de leche materna.
- ✓ Le da mucha importancia a "las veces" que mama el niño. Fija horarios. "¿está mucho en brazos?".
- ✓ Considera fechas claves cuando el niño cumple 6 meses y un año. Lo que antes era bueno puede volverse malo. Después del año tienen que dormir ambos toda la noche.
- ✓ Cualquier situación antes considerada normal será tratada como un problema y culpa de la lactancia materna: niños sin dientes hasta el año o más, de piel clara, delgados, que no muestran interés por otros alimentos o por muy pocos, celos entre hermanos, etc. Estas circunstancias, simplemente, existen entre niños sanos.

Uno de los ejemplos más patéticos es este del autor del "duérmete niño":

"Estamos totalmente a favor de la lactancia materna, pero no podemos aprobar que el pecho se convierta en un chupete. Los órganos humanos han de utilizarse para la función que les ha sido encomendada, en este caso, para amamantar al niño cuando Sí tiene hambre, no como forma de consuelo". Eduard Estivill

No por ser médico automáticamente sabemos de lactancia. No por ser especialistas en pediatría, ginecología o medicina de familia, automáticamente somos expertos y resolvemos dificultades

sobre lactancia materna.

Esto NO ES ASÍ.

Por desgracia es más bien al contrario.

El Dr. José María Paricio Talayero, pediatra y experto en lactancia dice: *"Las madres deben huir de los médicos a la hora de amamantar. Al menos, mientras no cambie la cosa"*.

Y si finalmente tienes que acudir a un sanitario, asegúrate de que tiene conocimientos en lactancia.

El Dilema de la Lactancia

Muchos son los que dicen "qué práctico, hoy en día puedes optar por una cosa u la otra ¿Pecho o biberón? Eliges y ya está". Como si fuera tan fácil. En realidad, el dilema es no poder elegir porque la realidad no te da opción. La medicalización del parto y la falta de apoyo hoy son los grandes problemas.

La mujer termina dejando un deseo inicial de dar el pecho a su hijo. El verdadero dilema viene luego y es la gran falta de conocimientos de los profesionales en torno a la lactancia en general y de muchos pediatras en especial.

En lo biológico no hay dilema. Dado que muchos obstáculos a la lactancia materna provienen de la falta de formación específica del cuerpo sanitario, en especial de los médicos, ES EXIGIBLE la inclusión de la misma en el pregrado y de modo permanente y revisable en el posgrado.

Amamantar viene de la raíz árabe amalgamar es decir que dos sustancias se transformen en una, sólida e indisoluble, esto habla del vínculo fundante de la psiquis del niño y de un disfrute esencial en el caso de la madre, esa simbiosis es necesaria y la lactancia materna la facilita.

En Resumen:

- ✓ El pediatra puede anticiparse a la lactancia en una entrevista prenatal.
- ✓ El pediatra debe tratar que el niño no se separe de su madre en la primera hora de vida y se le ofrezca el pecho. Luego hay tiempo de revisar al niño y realizar medidas profilácticas.
- ✓ El pediatra enseñará las bases para un amamantamiento satisfactorio y con disfrute.
- ✓ El pediatra trabajará en equipo y éste actuará con líneas de acción similares.

- ✓ El pediatra intervendrá si le piden ayuda o cuando vea conductas riesgosas.
- ✓ El pediatra revisará al niño para confirmar que está sano.
- ✓ El pediatra dará pautas de puericultura en forma oral y escrita adecuándose a las pautas culturales de las familias que asiste.
- ✓ El pediatra desaconsejará el uso de biberones o chupetes.
- ✓ El pediatra pesará al niño o a la niña a las 24 horas de nacido si su mamá ha recibido suero en las últimas dos horas del nacimiento.
- ✓ El pediatra recomendará el contacto con un grupo de apoyo.
- ✓ El pediatra dará pautas de control y solución de la congestión mamaria de la bajada de la leche.
- ✓ El pediatra citará al niño para la primera consulta a los 4 días de nacido.

Todo comienza con el fenómeno del big-bang o con el día 1 del Génesis, luego el caldo de la vida y el surgimiento de los homínidos: Aquí estamos; mamíferos superiores, bípedos, cerebrales y con sentimientos (con tres cerebros: el reptiliano, el límbico y el pensante). Así se inicia la historia de la especie humana y del alimento completo y funcional perfecto: la leche materna.

Se ha tratado de dar explicaciones genéticas y biológicas, de historia, de antropología, de psicología y de sociología al acto de amamantar, pero todos estos conocimientos no han bastado para describir y abarcar todas las implicancias.

Final: Hacer del quehacer, una práctica que se disfrute. Tratar que la ética sea la guía en este camino.

Bibliografía consultada

- Escardó, F. *¿Qué es la Pediatría?* Editorial Columba, Buenos Aires, 1956.
- Kent JC, Hepworth AR, Sherriff JL, Cox DB, Mitoulas LR, Hartmann PE. Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 months of lactation. *Breastfeed Med*. 2013; 8:401-407
- Kent JC, Mitoulas LR, Cregan MD, Ramsay DT, Doherty DA, Hartmann PE. Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day. *Pediatrics*. 2006; 117(3): 387-395.
- Lawrence, Ruth *Lactancia materna. Una guía para la profesión médica*. Elsevier:6ª. Ed.2007.
- Moossavi S, et al. Composition and variation of the human milk microbiota are influenced by maternal and early-life factors. *Cell Host & Microbe* 2019; 25: 324-325.
- Rollins NC, Bhandari N, Hajeerhoy N, Horton S, Lutter CK, Martines JC, et al. ¿Por qué invertir, y lo que se necesita para mejorar las prácticas de lactancia? *The Lancet* 2016; 387: 491-504.
- Sager, G. Banco de Leche para Pronap. https://www.academia.edu/14163359/Banco_de_Leche_Materna_para_Pronap
- Victoria CG, Bahl R, Barros AJD, Francia GVA, Horton S, Krasavac A, et al. La lactancia materna en el siglo 21: epidemiología, mecanismos, y el efecto de toda la vida. *The Lancet* 2016; 387: 475-90.

*Dr. Gustavo H. Sager

Doctor en Medicina. Pediatra Consultor. Docente Autorizado de la Cátedra de Pediatría B UNLP.

Creador del Primer Banco de Leche Materna de la Argentina en el Hospital San Martín de La Plata. Secretario del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

EL LUGAR DE LA CULTURA EN LAS INTERPRETACIONES E INTERVENCIONES EN SALUD. DIÁLOGO ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y LA MEDICINA



DRA. SUSANA ORTALE*

Introducción

La salud constituye la dimensión vital por excelencia, el modo de transitar la vida que sintetiza en su resultado -el estar sano o enfermo- el conjunto de aspectos o dimensiones que sustentan la existencia individual y social: lo ambiental y lo sociocultural, que definen sus condicionantes y significados; lo económico y político, que otorgan los recursos en que se expresa; lo biológico y lo psíquico, que constituyen su sustrato genético y existencial (Haro Encinas, 2000).

La importancia de la interdisciplina en el campo de la salud es un hecho ampliamente reconocido y la consideración de la confluencia de factores de diversa índole en su comprensión tiene larga data.

Asumiendo la universalidad de algunas cuestiones -como es el caso de los padecimientos y la muerte en sus distintas formas de manifestación-, también es cierto que se plantean desde realidades, interpretaciones, preocupaciones, lenguajes, acciones, etc., que forman parte de contextos socioculturales específicos.

Las iniciativas dirigidas a comprender el significado de lo social y de lo cultural para responder a interrogantes planteados por científicos sociales y también desde el sector de la salud, han mostrado grandes potencialidades pero también dificultades.

Tematizar sobre este aspecto, tal vez indiferente u obvio para algunos, se deriva de la preocupación de otros, sobre la utilización del

concepto de cultura o de factores socioculturales como una categoría explicativa o interpretativa de comportamientos, condiciones de salud, cumplimiento de tratamientos, uso de servicios, etc.

En esa dirección, el presente capítulo plantea algunas observaciones sobre dicho uso, recurriendo a revisiones y a experiencias de trabajo que reúnen a la antropología y a la medicina.

El objetivo del mismo es insistir sobre cuestiones que renovadamente atraviesan -muchas veces perturbando- el diálogo interdisciplinario y fundamentalmente la práctica médica.

Se espera que la reflexión que se propone suscitar, antigua pero aún necesaria, contribuya a fortalecer una comprensión integral de individuos y grupos, de los problemas de salud que los aquejan y de las respuestas dirigidas a resolverlos.

Para este objetivo, omito las críticas al dualismo cartesiano, al positivismo, al biologicismo, etc. de la que ha sido objeto, y continúa siendo, la medicina científica occidental. Considero que las mismas, han saturado sin pregnancia¹ o al menos son de dominio de gran parte de los lectores.

Como estrategia expositiva, invertiré el espejo, dando lugar a planteos generales que reúnen a

¹ Específicamente, me refiero al uso maniqueo y cosificado, de la categoría Modelo Médico Hegemónico elaborada por Eduardo Menéndez (1978 -y numerosas obras posteriores-) que hacen quienes trabajan en el sector salud -entre muchos otros-.

la antropología y a la medicina social y a la auto-crítica disciplinar, observando cómo aparece la dimensión cultural en los estudios sobre salud/enfermedad/atención. Entiendo que tal decisión puede resultar eficaz para encontrar y emprender desafíos comunes.

Luego exhibiré cómo los aspectos sociales y culturales están presentes en la atención médica y en las explicaciones dadas por los profesionales sobre sus relaciones con la población que atienden y cómo la caracterizan, para lo cual ejemplificaré con la atención pediátrica llevada a cabo en hospitales públicos y en centros de atención primaria del Gran La Plata.

Sobrevolando la relación cultura/sociedad-salud/enfermedad

Se reconoce ampliamente que considerar al hombre desde el aspecto biológico significa no comprenderlo en su particularidad e integralidad, siendo su condición biológica uno de sus componentes.

Los hombres somos variados porque estamos orientados por esquemas culturales específicos, por sistemas de significados históricamente creados, en virtud de los cuales conformamos y dirigimos nuestras vidas (Geertz, 1989). Las experiencias y situaciones en las que el hombre nace y se desarrolla condicionan su biología la que no puede separarse de la cultura y de la organización social.

Las condiciones objetivas de vida ligadas a la posición de las personas en la estructura de una sociedad definen cierta probabilidad de morir o enfermar de un modo particular y de lograr la cura.

La cultura, entendida en sentido genérico como el fundamento simbólico de la vida social que se expresa en las representaciones sobre la realidad y en las orientaciones para la acción, permite comprender cuáles son los códigos socialmente establecidos y compartidos de interpretación de la realidad y de interacción social. Podemos decir que ella regula el comportamiento de los integrantes de un grupo, en correspondencia con la estructura y el funcionamiento social.

De modo tal que las características socioculturales a la vez que condicionan la salud, condicionan su reconocimiento, el de la enfermedad y su tratamiento; los ejemplos de su variabilidad son abundantes.

La salud/enfermedad/atención ha dado lugar en todo tiempo y espacio a la construcción de representaciones y prácticas sobre los mismos². Cada sociedad tiene sus propias definiciones, las cuales no son estáticas, sino que se modifican en tanto cambian las circunstancias particulares y las cosmovisiones dominantes que les dieron origen (si bien en distintos momentos, el estatus de las enfermedades mentales y de la homosexualidad por ej., dan cabal cuenta de ello).

Los problemas de salud, los padecimientos y daños, comprometen el centro de la subjetividad y la reproducción de cualquier sociedad. Siguiendo a Wellin (1977), tales son las generalizaciones empíricas sobre las que se basa la Antropología Médica:

- ✓ la enfermedad es un hecho universal en la experiencia del hombre,
- ✓ todos los grupos humanos desarrollan técnicas y asignan roles para enfrentarla,
- ✓ todos los grupos humanos poseen un sistema de creencias, conocimientos y valores para explicarla.

Desde una concepción cultural/relativista, se plantea que una enfermedad es tal sólo si es reconocida y definida por la cultura, habiendo incontables ejemplos de la gran variabilidad en la definición e interpretación de los fenómenos fisiológicos, por mencionar los que constituyen el sustento de las definiciones biomédicas. Ellos son utilizados como base para etiquetar una condición u otra como enfermedad, por lo que la enfermedad es una rotulación basada en el juicio humano acerca de cierta condición existente en el mundo, juicios por cierto negativos porque la enfermedad es indeseable (Conrad, 1982).

En todas las sociedades existen pues, padecimientos, dolores, daños, molestias o fenómenos morbosos muy diferentes entre sí. Asimismo, existen diferencias profundas entre grupos en lo que respecta al sufrir y al modo de reaccionar ante las enfermedades.

Más allá de la complejidad que supone definir qué es “enfermedad”, podemos advertir que en ella se entrecruzan: a) un hecho objetivo que indica una alteración de algún órgano, función, capacidad; b) la percepción individual de dicha

² Para el caso de la biomedicina, diversos investigadores han rastreado la construcción histórica de las nociones colectivas de enfermedad y enfermo en Europa occidental (Herzlich y Pierret, 1989; Foucault, 1990; Sevalho, 1993; entre muchos otros).

alteración; c) una interpretación (científica, técnica, religiosa, moral) derivada de los conocimientos, ideas, prejuicios e intereses de la época, que sirve como guía operativa.

Berlinguer (1994) plantea que para el individuo, el fenómeno enfermedad involucra el estar enfermo (en donde las desigualdades sociales expresan en las probabilidades de enfermarse y sanar); el sentirse enfermo (la percepción influida por la cultura, la clase de pertenencia, el género, la edad); identificar la enfermedad (la forma en que la percepción de síntomas singulares confluyen o no en un diagnóstico que lleve a buscar una terapia o de iniciar acciones que impidan el avance de la enfermedad); poder estar enfermo (dependiente de desigualdades y discriminaciones sociales).

A partir de ello se puede apreciar cómo la enfermedad es vivida y afrontada, preguntar qué consecuencias tiene para el sujeto y qué comportamiento suscita en los otros. Desde ese punto de vista, dicho autor esquematiza de la siguiente manera las facetas de cualquier enfermedad: sufrimiento, diversidad, peligro, señal y estímulo.

El malestar, padecimiento o sufrimiento que acarrea la enfermedad, no es culpa, idea presente en mayor o menor grado en casi todas las culturas.

La idea del enfermo como sujeto responsable³ y transgresor, se representa continuamente en nuevas formas, estando muy enraizada en el ánimo popular. La noción de estilos de vida -morbígenos-, por ej. abre camino a la idea de que hay una complicidad del enfermo en el origen de la enfermedad. Tal actitud no advierte los condicionamientos y las presiones que determinan (aun dejando espacio a las elecciones personales) el estilo de vida o el impulso auto-destructivo de las personas.

La enfermedad representa también una diferencia: más que como diversidad, la enfermedad es definida habitualmente como desviación. Pero ¿cuál es la norma? La respuesta es difícil de evaluar, sobre todo si advertimos la variación de las mismas (exceso de peso, glucemia, colesterol, etc.). La distinción normalidad/anormalidad y luego la asociación anormalidad/enfermedad

es compleja; las fronteras son variables y a veces inciertas.

Algunas enfermedades, en todas las épocas, han sido consideradas un peligro: el riesgo directo para la salud de los otros se liga frecuentemente a la búsqueda de un chivo expiatorio sobre el que recaen los problemas o dificultades de la comunidad y de la convivencia familiar y social.

El problema que se observa es que la motivación del contagio y la exigencia legítima de aislar la fuente del mismo, se acompaña de otras razones o prejuicios extra sanitarios.

La enfermedad de una persona determinada, íntimamente ligada a su existencia, rara vez es un caso aislado. Iguales procesos se verifican en otras personas y expresan las condiciones de vida que actúan sobre la colectividad. La interpretación de estos fenómenos proporciona muchos datos de naturaleza cultural, económica y social, representan una señal que ayuda a comprender lo que ocurre en varios grupos o sociedades y orienta para prever mejor el futuro.

El problema consiste en que esa señal permanezca oculta o se presente distorsionada. Las estadísticas de salud son una prueba de cómo la organización sanitaria contribuye a soslayar las señales colectivas de enfermedad. Las instituciones sanitarias producen datos tales como: consultas, internaciones, días/cama, gastos, mientras que la información sanitaria sustantiva: qué enfermedades, en qué zonas y grupos de población, es a veces ignorado o imposible de reconstruir.

La exigencia fundamental a la epidemiología es que ponga de relieve la señal. Y esta función de ampliar la señal no debería ser privativa del sector salud.

En tal sentido, cuando destacamos la importancia de los factores socioculturales en la explicación de la salud/enfermedad/atención, estamos cuestionando lo que la epidemiología informa de manera simple, cuestionamiento que de manera lúcida y propositiva ha realizado Menéndez (2008) al desarrollar el concepto de epidemiología sociocultural⁴, de enorme potencial heurístico y explicativo. Y ello constituye a

3 En algunos cursos dictados por médicos especialistas en problemas nutricionales, he escuchado el concepto de "madre desnutri-génica" para hacer referencia a atributos individuales generadores de desnutrición en los niños.

4 Desde esta perspectiva, en la evaluación de los problemas de salud y enfermedad y de los cuidados y terapéuticas, debería considerarse la participación de la biomedicina, los curadores o sanadores de modelos alternativos (incluyendo cultos religiosos), los grupos de autoayuda y la población.

nuestro juicio, el estímulo y desafío que se podría asumir elaborando propuestas concretas y ajustadas al norte de la transdisciplina.

Considero que sería el ejercicio más fructífero para diluir las ontologías disciplinarias que han fragmentado la realidad -persuadiéndonos incluso que sus compartimentos existen tal como ellas los presentan-, y para aportar a intervenciones alineadas a un conocimiento más complejo y ajustado a la misma.

A continuación presentaré algunas cuestiones que se identifican en los trabajos antropológicos sobre salud, particularmente al tipo de construcción de “lo cultural” que se observa en ellos, en qué sentido contribuyen a ampliar la señal en el campo de la salud y ciertas cuestiones pendientes.

Usos del concepto de cultura en estudios de Antropología y Salud

Para emprender la indagación sobre el uso del concepto de cultura, no partiremos de las definiciones, diversas por cierto (modo de vida; herencia social; significados compartidos; maneras de pensar, sentir, creer, actuar, vivir de distintos grupos sociales; depósito del saber colectivo; conducta aprendida; normas que rigen la conducta; ambiente hecho por el hombre; representación simbólica de la base material de la sociedad, etc.), ni buscaremos la coherencia en sus aplicaciones.

Adhiero a Menéndez (2000) quien plantea que si bien las definiciones expresan el deber ser y constituyen un punto de partida, no resuelven el problema del significado del concepto tal como se utiliza en situaciones concretas.

En ese sentido, recupero a Rosaldo (1991) cuando advierte que ciertos fenómenos humanos parecen más atractivos que otros para el análisis cultural, tornándose más “culturales” que otros. También advierte la estrecha base sobre la que se sostiene el concepto de cultura, al excluir de su competencia a determinados grupos humanos, en especial: la comprensión del “nosotros”, “invisibles culturalmente”, transparentes a nosotros mismos.

Ahora bien, yendo al tema específico, a partir de una subdisciplina conocida como Antropología Médica, Antropología de la Medicina o Antropología de la Salud (según los contextos), se

desarrollaron -luego de la segunda guerra mundial-, investigaciones empíricas y producciones teóricas sobre procesos sociales y representaciones culturales de la salud, la enfermedad y las prácticas de atención en “otras” culturas. Ese conocimiento, original y valioso en sí mismo, en diálogo con la antropología biológica, la medicina, la psiquiatría, la salud pública, contribuyó a una mejor comprensión de nuestra propia condición humana, avanzando progresivamente en el estudio de las sociedades contemporáneas.

En ellas, desde enfoques etnomédicos, médico-críticos y de la antropología médica aplicada, se observa de manera renovada la diversidad en los modos de estar sano/enfermo/morir y de entender y atender el fenómeno universal del proceso salud-enfermedad-atención, diversidad que está atravesada por procesos que generan desigualdades sociales.

Las problemáticas abordadas abarcan, entre otros: las distintas expresiones y etiologías de los malestares, padecimientos, enfermedades; los síndromes de filiación cultural; los sistemas de creencias y prácticas respecto a la salud-enfermedad-atención; los sistemas médicos y curativos; los modelos médicos (hegemónico, alternativos o subordinado, de auto-atención); la medicalización; la adherencia terapéutica; la eficacia simbólica; cuerpos y sufrimientos; las redes de autoayuda, estudios orientados a mejorar o crear programas de prevención, promoción, atención; intervenciones de salud comunitaria en entornos interculturales, entre otras problemáticas. Como rasgo distintivo, el estudio de tales cuestiones atiende especialmente a la dimensión simbólica, esto es, a los significados y a los valores y normas que involucran.

Tal vez a ello obedece la limitada utilización de los aportes antropológicos, se percibe que su sesgo cualitativo, si bien permite comprender y explicar, no colaboraría con la evidencia necesaria para decidir.

Al respecto, y con relación a temas de salud, Menéndez (2000) señala que aunque los antropólogos reconocemos explícitamente que los factores culturales operan en todo tipo de saberes sobre la salud/enfermedad/atención, focalizamos las investigaciones y/o reflexiones en las enfermedades de “otros”: en enfermedades “tradicionales”, populares, en los rituales de sanación, en la herbolaria, interpretadas -incluso por antropólogos culturalistas de la década

de 1940-, como la expresión de mentalidades o culturas “atrasadas” o como un “obstáculo” al cambio.

También observa la exclusión del campo de la biomedicina en los estudios antropológicos aunque se la reconozca como un modelo cultural más, esto es, como etnomedicina.

Los estudios se han centrado en aspectos mágicos, religiosos, en los sistemas médicos “tradicionales” como objetos de investigación privilegiados: del campesinado de extracción indígena y luego de los pobres urbanos (Menéndez, 1985), pero el uso de medicamentos, las consultas, los diagnósticos, las cirugías, etc. no suelen estudiarse como procesos culturales. La biomedicina, contiene problemas relevantes para el análisis social pero continúa siendo un espacio vacío en los estudios antropológicos al menos latinoamericanos, en gran medida por corresponder a un dominio de “invisibilidad cultural”⁵.

Así por ejemplo, la “magia científica” presente en los tratamientos con placebos ha sido escasamente abordada, pese a representar la reformulación médica de la eficacia simbólica asociada a las curas. La eficacia simbólica como mecanismo de explicación en la curación chamánica y psicoanalítica referida a los efectos de la sugestión del acto terapéutico (Lévi-Strauss, 1968), contribuyó a inaugurar un fértil programa de investigación que interpelaba al positivismo dualista que divide cuerpo y mente. Estudios sobre el efecto placebo muestran la fuerza del imaginario, de las significaciones que el enfermo atribuye al acto médico. Pese al sostén de la psicoimmunoneurología⁶, la interpretación médica del efecto placebo, radica en que responde a “necesidades psicológicas” de los individuos, retomando el dualismo cuerpo/mente. La cura, argumentan la mayoría de las veces, no es cura, se trata de un proceso que “se dio en la cabeza”, “porque creían en ella” (Le Breton, 1995).

5 Un ejemplo de “descubrimiento” de dicha invisibilidad fue el estudio realizado hace casi 20 años en el Hospital de Niños de La Plata. Originado en observaciones e interrogantes del Dr. Luis Fumagalli sobre el manejo de la fiebre por parte de residentes y de médicos formadores, sus resultados fueron reveladores de prácticas pediátricas cotidianas que manifestaban la distancia de las indicaciones médicas en su tratamiento, debido a la incidencia de factores extracientíficos (Fumagalli, Ortale et al., 1999; Ortale y Fumagalli, 2000).

6 La misma plantea la función esencial del sistema nervioso central en el condicionamiento del sistema inmunitario y, en general, de las defensas y del complejo equilibrio del organismo humano.

Las oportunidades para la investigación antropológica ofrecidas por el uso frecuente de placebos por parte de la biomedicina, no se han aprovechado; no se ha profundizado su estudio en términos culturales.

Además de la falta de estudios antropológicos sobre la eficacia de la biomedicina, la producción antropológica se sigue caracterizando por la escasa significación otorgada a la eficacia terapéutica en las descripciones y análisis etnográficos de “otras” culturas. Se describen síndromes culturalmente delimitados (empacho, pata de cabra, mal de ojo) y sus respectivas terapias, sin reparar en la eficacia -o no- de las mismas, en la cantidad de casos de mortalidad o de enfermos y en un conjunto significativo de datos que abonarían al fortalecimiento de una epidemiología sociocultural (Menéndez, 1998, 2008). ¿Cuál es la eficacia de esas terapias alternativas?, ¿disminuyen, alivian o eliminan el daño? Sería necesario explorar en detalle la eficacia de las medicinas (así como la de los rituales y la adscripción religiosa) y su mutua articulación, particularmente la de las medicinas alternativas sobre las que pesa mayor exigencia de demostración y sobre las cuales existen en ese aspecto escasos estudios. La medicina “tradicional”, “popular” o alternativas: ¿son eficaces?, ¿curan realmente?, ¿cómo lo hacen?, ¿por qué se practican?, ¿qué tanto hay de eficacia simbólica?, ¿es conveniente seguir manteniendo la dicotomía eficacia simbólica/eficacia pragmática? Tal como observa Menéndez (1998), luego de haber transitado etapas prolíficas de estudios antropológicos dedicados a la descripción de la medicina tradicional o popular, se registra desde hace aproximadamente tres décadas, cierto desdén sobre estas prácticas, sin mucha importancia ni implicancias para la salud de la población. Lejos de representar resabios atávicos de culturas exóticas, la realidad -más dinámica e indiferente a los temas académicos de moda- muestra cómo dichas medicinas se actualizan, redefinen, surgen, consolidan y usan en la vida cotidiana. Su exploración podría iluminar, entre otras cuestiones, sobre las condiciones de salud de la población, sobre las limitaciones de la medicina hegemónica y sobre la eficacia de los recursos alternativos.

Desde ya, el marco de observación de la disciplina incluye variables culturales e ideológicas en el estudio de diversas prácticas asistenciales.

Pero su eficacia terapéutica y trascendencia epidemiológica, no han sido abordadas.

Frente a esto, algunos antropólogos afirman que no es competencia de la antropología registrar datos de morbi-mortalidad, sino de la medicina y de la epidemiología. Si bien no adhiero a esos planteos, “podrían no ser incorrectos, pero entonces tendríamos que explicitar qué estamos buscando cuando hacemos este tipo de descripciones del proceso de salud/enfermedad/atención, así como cuando excluimos o incluimos determinados factores” (Menéndez, 2000).

Numerosos antropólogos que destacaron la importancia de los rituales curativos y sus funciones de integración social, señalaron sobre el peligro de quedar presos en la fascinación por los rituales simbólicos.

Así por ejemplo, Víctor Turner decía en los años sesenta:

No se ha reconocido suficientemente la estrecha relación de las creencias sobre brujería con las altas tasas de enfermedad y mortalidad que afligen a la mayor parte de las sociedades tribales. La enfermedad, como la lluvia, presenta con frecuencia distribuciones fuertemente localizadas. Los análisis sobre brujería deberían incluir en el futuro estadísticas locales de muertes y enfermedades, ya que es muy probable que el carácter repentino e impredecible de las afecciones graves explique en parte el carácter azarosamente maligno e inmotivado atribuido a muchos tipos de brujería. (...) la situación de la salud pública de los ndembu, como la de la mayor parte de los africanos, es muy insatisfactoria (...) El hecho de que un rico y elaborado sistema de creencias y prácticas rituales proporcione un conjunto de explicaciones para la enfermedad y la muerte dando a la gente un falso sentido de confianza de que dispone de medios suficientes para hacer frente a la enfermedad, en modo alguno contribuye a la elevación del nivel de salud ni al aumento de la esperanza de vida. (Turner, 1980).

Salvando distancias en múltiples sentidos, y como contrapunto, en las conclusiones de mi tesis doctoral (Ortale, 2003) indicaba que “una dimensión no contemplada inicialmente en el estudio, que surge de las entrevistas como eje de indagación y potencial variable explicativa de los perfiles de salud/enfermedad diferenciales dentro de las condiciones de vida de hogares pobres, se vincula con la adscripción religiosa”.

En este caso el foco iluminó algunos aspectos (sociodemográficos, económicos, institucionales, políticos, las representaciones y prácticas médicas y “legas” sobre desnutrición infantil) y soslayó otros que se revelaron importantes para comprender diferenciales de morbilidad/mortalidad infantil dentro de un conjunto de hogares pobres.

Por otra parte, podemos decir que es escasa la inclusión de la dimensión económico-política en la etnografía y/o en el análisis de muchos estudios antropológicos, lo cual explica el insuficiente avance en la articulación de los niveles macro y micro social. Su indagación articulada, contribuiría a entender, por ejemplo, por qué procesos de crisis económica, contextos de pauperización, o a la inversa, no se reflejan linealmente en peores o mejores indicadores de morbi-mortalidad. Consideramos que esta falta de elucidación está en la base de algunas hipótesis o afirmaciones del sentido común experto según las cuales las tendencias epidemiológicas -positivas- se atribuyen a las intervenciones del sector salud, y las negativas a políticas económicas, a falta de educación, de cultura o empobrecimiento de la población. ¿Por qué no podríamos plantear que las mejoras, (o al menos el mantenimiento o no empeoramiento) derivan de la vapuleada medicalización? ¿Por qué no pensar que son los recursos o saberes de los “legos” (apropiados simplificadaamente de los saberes biomédicos) los que actúan positivamente en el mantenimiento de ciertos niveles de salud en contextos de crisis de la economía y del sector sanitario? Como se ha dicho más arriba, los cuidados “legos” constituyen una dimensión estructural en todo tiempo y en todas las sociedades.

De hecho, a nivel micro social, el hogar es el primer nivel de atención, y en esto la Antropología ha hecho aportes sustantivos. En él se da la mayor frecuencia y recurrencia de padecimientos y de enfermedades, es el lugar en donde se inicia la carrera de enfermo, donde se da el mayor número de detecciones, diagnósticos, actividades de atención y tal vez de curación (Menéndez, 1992). Sea en forma directa o mediando, en el hogar se constituyen y actúan alguno de los principales determinantes de la morbilidad y de la mortalidad, en particular infantil. Es alrededor del hogar que se organizan las principales redes sociales que intervienen en la salud/enfermedad/atención. Estos y otros aspectos, ya sea que

acentuemos sus efectos positivos o negativos en la salud de sus integrantes, fundamentan su consideración como potencial variable explicativa de los problemas de salud específicos, y no sólo como variable dependiente de determinaciones político económicas o de intervenciones sectoriales.

En síntesis, a nivel genérico reconocemos lo cultural en todo proceso de salud/enfermedad/atención, pero en los trabajos específicos se identifica en determinados padecimientos, actores y problemas y se excluye en otros.

Como se desprende de este recorrido superficial, no es una definición de cultura abarcativa de la gama total de dimensiones significativas de una sociedad la que se encuentra en la base de su uso. Más bien, es el interés sobre determinados aspectos de lo cultural el que instituye la conceptualización dominante sobre los factores culturales, y es ella la que circunscribe el estudio antropológico del proceso de salud/enfermedad/atención (Menéndez, 2010).

En lo que sigue, haré referencia a la relación entre la biomedicina, los cuidados “legos” y las medicinas alternativas ejemplificando cómo los factores culturales se visualizan en casos concretos de atención pediátrica y cómo se refleja el uso de la noción de cultura en sus discursos referidos a la población que atienden.

Usos del concepto de cultura en la atención pediátrica

Apoyaré y complementaré algunas de las cuestiones conceptuales enunciadas a través de la información surgida de entrevistas con médicos⁷ pediatras de hospitales públicos y de centros de atención primaria (CAPS) del Gran La Plata. Las mismas, junto con entrevistas realizadas a mujeres/madres, fueron realizadas en diversos trabajos de campo (concentrados entre 1995-2000) relacionados con el que sostuvo

7 Aún reconociendo la feminización del trabajo médico en los servicios públicos, especialmente en servicios de atención primaria, omitiré en general, en la exposición, las distinciones de género (los/las pediatras, los/las médicos/as, niños/niñas). Tal decisión, consciente de las probables críticas que apuntan a la colonización de mi subjetividad por parte de la sociedad patriarcal, obedece a cuestiones de fluidez en la escritura y lectura, y a la cuestión sustantiva de que su importancia radica en la manera en que esas distinciones actúan en las relaciones sociales concretas, no en las expresiones formales. Y en tal sentido, sugiero a los lectores constatar si en las internaciones pediátricas, se acepta a los padres como responsables del acompañamiento de sus hijos y que pernocten con ellos; caso contrario, incidir para que eso sea posible.

mi tesis doctoral sobre desnutrición infantil de causa primaria (Ortale, 2003)⁸.

Las preguntas de las entrevistas giraron en torno al saber médico sobre desnutrición infantil: sobre los principios teóricos y técnicos en los que basaban sus intervenciones (cómo detectaban, diagnosticaban, explicaban su causalidad, actuaban y evaluaban su intervención); qué factores limitaban, imposibilitaban o favorecían la detección, tratamiento y cura de los niños desnutridos; cuáles eran sus conocimientos sobre los hogares y sobre las estrategias populares o medicinas alternativas; cómo interpretaban las percepciones maternas de la desnutrición y el cumplimiento de las recomendaciones médicas; cuál era su capacitación para desarrollar actividades de atención primaria, entre otras.

La información que responde a las mismas se organizan en tres ejes temáticos

- ✓ Condiciones de trabajo, conocimiento y uso de normativas de diagnóstico y tratamiento de niños/as desnutridos y apreciación de programas de salud.
- ✓ Abordaje de la desnutrición.
- ✓ Apreciaciones sobre la receptividad y respuestas de las madres al diagnóstico y tratamiento y sobre el uso de medicinas alternativas.

En la exposición distinguiré el análisis de la información provista por los pediatras de hospitales, de la provista por pediatras de CAPS, ya que se identificaron notables diferencias en varios de los aspectos indagados⁹ (Ortale, 2005).

Cabe decir que a mediados de 1990, el análisis de fuentes secundarias reflejaba muchos problemas del sector salud para intervenir sobre la desnutrición primaria, a saber:

Los datos sobre la situación nutricional en la Argentina eran asistemáticos, fragmentarios y discontinuos siendo mayor déficit de datos sobre las deficiencias de micronutrientes.

La escasa información se debía a su falta de obtención, fallas en el registro, procesamiento y difusión.

Las normas oficiales para las actividades de

8 Por problemas de espacio, excluyo el sugerente material de las entrevistas a las madres.

9 Ana, José, Juan, María y Martín son los nombres ficticios de los pediatras que trabajaban en hospitales. Eduardo, Gabriela, Lorenzo, Malena, Raúl, Susana y Violeta los de aquellos que trabajan en los CAPS.

atención infantil, particularmente para el control del crecimiento, existían y eran conocidas.

Dichas normas no eran utilizadas rutinariamente en la asistencia pública hospitalaria.

La ausencia de normas sobre alimentación infantil determinaba un vacío acerca de los criterios que los pediatras adquirirían en su formación.

La alimentación constituía un tema banal al que se le brindaba poca o nula atención en la formación de pre y post-grado.

De acuerdo con una encuesta provincial (Ministerio de Salud Pcia. de Bs. As. PMI, 1998), las recomendaciones alimentarias dadas por los pediatras arrojaban que sólo un 15% indicaba una dieta con adecuada densidad energética.

Muchos trabajos señalaban la necesidad de capacitación sistemática a los pediatras y equipo de salud sobre la alimentación en el primer año de vida.

La capacitación de los médicos sobre esta problemática dependía de sus intereses y posibilidades.

Los programas de salud infantil eran discontinuos por dificultades presupuestarias y organizativas.

Había carencias de insumos básicos o irregularidad en su provisión en los distintos niveles asistenciales, incidiendo especialmente en la capacidad resolutoria de los CAPS.

Inadecuada y/o insuficiente articulación entre los niveles asistenciales.

Un modelo de atención centrado en la reparación más que en la prevención, resultando una atención más cara e ineficaz.

Todos estos señalamientos, muchos de ellos aún vigentes, se identificaron en mayor o menor medida en los discursos de los médicos entrevistados, con diferencias entre los dos grupos indicados. Esto se debía a la manera en la que las respectivas instituciones. Pese a que el saber médico se supone homogéneo y que el quehacer profesional está rutinizado y normatizado en alto grado, esas diferencias se debían a la manera en que las respectivas instituciones estructuraban sus prácticas de atención.

1) Con relación a las normativas, condiciones de trabajo y a la evaluación de las políticas sanitarias, las diferencias encontradas entre médicos de hospitales públicos y de CAPS y se reflejaban, para el caso de los pediatras de hospital, en: el no cumplimiento de las normas destinadas al control de salud y del crecimiento: “no lo evaluás detenidamente. No se puede.

Es imposible”, la pérdida de pacientes por imposibilidad de seguimiento vinculada a la atención despersonalizada y cambiante, un mayor peso de las determinaciones institucionales que imponían la atención de patologías, sesgos profesionales más marcados por la subespecialización, inespecificidad para abordar las problemáticas del crecimiento y del desarrollo por subestimación de la problemática, reflejada en la inexistencia de un código de registro específico en los registros hospitalarios sobre el estado nutricional de los niños atendidos. Las normas de control de crecimiento:

“No se usan por falta de tiempo pero en realidad está bastante normatizado que hay que usarlas. Es difícil. Muchas veces te tenés que adaptar a las condiciones de trabajo que te impone el servicio. El tema es la demanda en los hospitales públicos, lo que es la prioridad (la patología), que es una locura. Se atiende apurado, y la presión de la gente no te permite hacer un trabajo como corresponde. Habría que hacer una estadística de cuántos pediatras pesan y miden al chico menor de dos años...y cómo lo hacen también. Es un problema pero si bien es un problema nuestro, porque no le vamos a escapar a la responsabilidad porque somos nosotros los que lo tenemos que hacer, también muchas veces las condiciones que trabaja uno te van relegando actitudes que son básicas.” (Juan)

La administración del tiempo no permitía seguir los protocolos de atención infantil, colocando en una situación de desprotección y riesgo a los niños/as (fallas diagnósticas) y a los médicos (mala praxis), situación que por otra parte era asumida por ellos como una responsabilidad individual.

Pese a las carencias y limitaciones de la atención hospitalaria, la misma parecía ocupar, según los médicos, el primer lugar en las preferencias de las madres.

“Igual eligen el hospital, saben que lo que no les hacen en la unidad sanitaria en el hospital se lo hacen: la radiografía, los análisis...le dan mucha importancia a una placa, entran a la consulta pidiéndote una radiografía y eso en la salita no se lo pueden hacer. Los análisis también se los hacés en el momento. Le descartás una infección en dos horas entonces...por ahí ellos en la salita están una semana.” (Martín)

A las reglas establecidas (dilación de los turnos, tiempo de espera, rotación de profesionales) y a su aparente “aceptación” o resignación, se anteponía, según los informantes, la importancia que las madres atribuían al diagnóstico precoz y certero, certidumbre basada en la confianza depositada en la tecnología médica.

“a las salitas la gente no quiere ir. No quiere porque o te cambian el médico, o el día que va, el médico no fue... y ese es el único médico que hay. En cambio en el hospital, si no fue el que la ve habitualmente siempre hay otro y el problema se soluciona. De última llevás el problema solucionado. Y a veces nosotros tenemos el antibiótico o el jarabe o el antitérmico como para darle, entonces.... Y hay gente que bueno, por más que le digas: “tenés la salita a dos cuadras”, no la sacás del hospital.” (María)

La lógica en la que se inscribía la atención era precisamente la de la práctica curativa, constataándose la fuerza de la eficiencia diagnóstica y de la eficacia terapéutica, aspecto central en el proceso de hegemonía alcanzada por la biomedicina.

En esa lógica, la desnutrición, como señal permanecía oculta y distorsionada: con frecuencia su magnitud era desconocida o malinterpretada. Las estadísticas de los hospitales registraban datos generales de la actividad médica y patologías:

“Del total de consultas que se hacen, la verdad es que no se sabe cuántos hay desnutridos. No, porque no se hace eso, de desnutrición no hay una estadística. Es más, en la estadística que el jefe de consultorio le pasa al jefe del servicio, mensual, él te pone: infecciosa, respiratoria, etc., pero vos ves los ítems y desnutrición no existe. La patología, sí, infección, te pone el porcentaje o te pone la cantidad total que hubo, pero...en la planilla que manejan para el registro de patología, no está”. (Ana)

Contrastando con el conocimiento abstracto y anónimo de la desnutrición y de los desnutridos que se visualizaba en los hospitales, los CAPS resultaban un ámbito propicio para el conocimiento profundo y para el involucramiento afectivo:

Los pediatras de los CAPS reflejaban mayor interés en la problemática a partir de la puesta en marcha de un “Programa de vigilancia y rehabilitación nutricional” y de la realización de un censo nutricional. Demandaban en mayor

medida la posibilidad de capacitación y actualización y si bien expresaban gran satisfacción por su relación con los pacientes, reconocían a menudo escasa capacidad resolutoria: su mayor compromiso con los pacientes los llevaba a un mayor grado de reflexión acerca de su tarea.

También el distanciamiento creciente entre la investigación médica y la actividad asistencial era destacada fundamentalmente por ellos:

“Yo creo que los debe haber fundamentos científicos, por supuesto, lo que pasa que a veces uno no tiene tiempo de ponerse a leer cada una de las cosas, a mí me pasa. Siempre decimos que los médicos de las unidades sanitarias nos venimos atrofiando. Cambian las normativas, es cierto. Y sí, y si no tenés la posibilidad del curso o de ampliar los conocimientos, de viajar a Buenos Aires a los congresos, te vas quedando con las normativas que tenías de antes y viene una mamá que lo llevó al Hospital...a mí me ha pasado, que lo llevó al Hospital y me dice: ‘Me dieron esta dieta’, y yo la leo y digo: ‘bueno, la mitad de las cosas que te daba... yo no se las hubiera indicado.’ (Susana)

Podemos observar que los fundamentos científicos de las normas no siempre eran conocidos, aceptando como criterio de autoridad el saber de quienes las elaboran:

“Mirá, las normas las hacen efectivamente los que más saben, a veces, ¿no?...” (Lorenzo)

Las prerrogativas que otorgaba la municipalidad para realizar cursos como parte de la carga laboral, no descomprimía el malestar de los médicos de los CAPS por los magros salarios, por las condiciones de trabajo y por la brecha salarial con relación a pares que se desempeñaban en hospitales u otras instituciones, no sólo privadas:

“Tenés que tener mucha energía para luchar contra el sistema. El médico de acá, que es el médico de trinchera...Yo trabajo desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde con una hora de descanso. Pero es la única manera de tener un sueldo que ronde un poquito más de mil...porque sino ganás setecientos...y te morís de hambre. Pero entonces el tiempo para el estudio no te queda. Tenemos 56 horas curso que yo las tomé siempre, alguna vez hasta me han dejado hacer alguno más. Pero parece que uno siempre, yo comparo con los médicos, compañeros míos del Hospital y trabajamos el

triple. Es un trabajo más desgastante porque tenés poco retorno para cultivarte. Eso es una cosa que el Hospital critica pero hay que estar.” (Violeta)

El acelerado avance científico y el cambio de normativas no se acompañaba de posibilidades de actualización, de allí los desfases en las indicaciones médicas:

“Pienso que va a seguir cambiando porque el descubrimiento va a ser cada vez mayor...de los nutrientes, de los micronutrientes, eh, de las necesidades, de la maduración del chico. A medida que se va descubriendo, se va acercando un poco más a lo que sería lo óptimo... ¿viste?, pero en el camino se van priorizando cosas, sin conocer que hay otras dando vueltas. Entonces...por ahí se mete la pata y uno va afinando la puntería. Y ahí eso depende también de cada chico.” (Violeta)

Así, los pediatras de los CAPS, procedían a una adecuación de las normas en función de las preexistentes o de los imperativos presentes en los programas de salud:

“Entonces bueno, si bien las pautas van modificándose, uno desde este nivel de atención primaria no las va modificando demasiado...a no ser, bueno, sí, que la información ya caiga, eh, y sea muy amplia... que sí o sí la tenés que aceptar, incorporar... y bueno, modificar en función de eso. Pero nos pasa, por lo menos a mí me pasa que trabajo ocho horas acá, que tengo el consultorio tres veces a la semana en mi casa, que tengo una familia, que hace que no tenga a veces el tiempo como para decir bueno, me siento a leer, a actualizarme, a buscar bibliografía. Tenemos anualmente 58 horas de curso; si se extiende más allá de ese tiempo, habría que devolver las horas con trabajo...eh, muchas veces no se hace.” (Susana)

Además de dichas razones, la flexibilidad en el uso de las normas se explicaba por la necesidad de contemplar particularidades individuales, regionales, étnicas, etc. interviniendo dosis de “suerte” y “arte” en los resultados ya que:

“La medicina no es una ciencia super-exacta... tiene sus bemoles y no todos los pacientes responden de igual forma a un tratamiento. También está esa posibilidad.

Eh, es, es medio arte a veces ¿viste?, a veces es medio suerte; prescribir lo correcto en el mo-

mento correcto...en dosis suficientes para salvar o curar una enfermedad. Es un decir, ¿no?, eso se puede extender a todo lo que sea medicina. La forma preventiva, cuándo conviene hacer la profilaxis, con las vacunas pasa algo similar... ¿Qué calendario es el mejor?, ¿el de Estados Unidos?, ¿éste?, ¿el de Europa? Son todos diferentes, ¿cuál tiene razón? No sé ¿viste?, ¿quién tiene la razón? Y sin embargo estamos hablando de una cosa tan simple que es: cuándo debés vacunar y con qué vacuna...y cuántas dosis. Imaginate con la comida...” (Lorenzo)

Podríamos plantear que esa heterogeneidad que reconoce Lorenzo, tiene como base perfiles epidemiológicos distintos entre países o regiones y además, que las razones absolutas están por fuera de la racionalidad científica.

Y en el mismo sentido, pero en un nivel distinto deberíamos pensar sobre la pertinencia de ciertas indicaciones médicas derivadas de normas y “planes culturales” pretendidamente universales, sobre sus posibilidades de realización o cumplimiento en condiciones concretas de vida de hogares pobres. La mayoría de las veces, los incumplimientos, los equívocos, no derivan de pautas inherentes a una supuesta “cultura de la pobreza”: lo que difiere es la capacidad de desarrollar pautas de vida apropiadas o “decentes” en una sociedad marcada por la desigualdad. Valentine (1970) hace alusión a ello cuando habla de “elasticidad de valores”: la sociedad inculca valores a grupos que no podrían ajustarse a ellos.

Así, el conocimiento de las condiciones de vida de la población y la experiencia de los pediatras de los CAPS, les permitían tomar precauciones acerca de las indicaciones y de los tratamientos, no sólo para lograr su adecuación sino también para evitar efectos iatrogénicos:

“He visto cómo viven y cambié algunas indicaciones, porque hay cosas que los pediatras decimos que son imposibles de realizar. Por ejemplo, qué sé yo, hacer vapor en una casa donde no hay una ducha. A mí se me quemó y no me olvido nunca más..., no se me quemó a mí...pero yo me sentí responsable de la desfiguración del rostro de una nena. Sabés que la nena se quemó toda la cara!... era una muñeca, después bajé la indicación de vapor, casi la tengo reducida a madres que conozco muy, muy bien. (...) de otro

caso similar me acuerdo que al chico le habían quemado no sólo la cara, le habían quemado el árbol respiratorio.... Yo no me olvido más. O sea que atender acá te lleva por lo menos unos cuantos minutos asesorarte de cómo...” (Violeta)

“A veces fallamos nosotros. Eh, no nosotros... la soberbia médica, de creer que el otro que no sabe nada y que no se da cuenta de nada, y resulta que las mamás se dan más cuenta de uno, que en quince minutos o en diez minutos tenés que ver al chico y vos decís, bueno, yo no le encuentro nada, está bien, y resulta que no está bien. Porque ellas lo ven las veinticuatro horas del día...y el chico, eh, es activo, es dinámico y bueno, vos lo ves acá que está tranquilo, quietito, lo revisás, no tiene nada...pero la madre sabe que algo tiene.

Este, entonces bueno, aunque yo no le encuentre nada..., le digo, bueno, yo no le encuentro nada...lo más probable es que tenga algo... entonces le digo: bueno, vamos a esperarlo o consultás en el Hospital o...venís mañana.” (Eduardo)

No obstante asumir que la desnutrición constituía un problema de salud prevenible, de diagnóstico técnicamente sencillo y tratamiento eficaz y barato y de hallarse estrechamente asociado con el aumento en las tasas de morbi-mortalidad, existía, con relación a la población que vivía en el área de influencia de los CAPS, un notable vacío de información epidemiológica y de actividad en terreno.

“Sí, claro, la gente (del CAPS) está capacitada, pero está desmotivada. Y la gente del barrio también... ¿para qué me vienen a joder, a llenar una encuesta, a hacer esto, a hacer lo otro, ¿para qué?’, ¿viste?, ‘si yo el laburo lo voy a seguir teniendo igual, si mis reclamos no los van a escuchar’, ¿viste?, están cansados, entonces como uno le pide cosas y están... así... ¿otra vez me venís a joder con esto!... si no vas a solucionar nada’.” (Responsable Plan Materno Infantil-Municipalidad de La Plata)

En este primer eje, observamos que las similitudes entre ambos grupos de pediatras tenían que ver con: el conocimiento de las normas y el reconocimiento de su utilidad (“establecer un

patrón de normalidad” constituyendo una “técnica para controlar desvíos de la normalidad”, “vigilar a la población, detectar cambios en el crecimiento y realizar un diagnóstico precoz”); el reclamo de una mayor articulación entre los niveles de atención (apreciación más acentuada en los médicos del hospital); la sobrecarga de trabajo; la escasa motivación para participar de programas debido a la discontinuidad de los mismos; la falta de recursos del Estado que permitan el cumplimiento de las normas y un adecuado tratamiento; la falta de datos sistemáticos; la formación recibida centrada en el estudio de las patologías y no de la salud; la poca relevancia dada en su formación al control del crecimiento y a la alimentación; el marcado sesgo asistencialista de su práctica.

“Mirá, yo te puedo hablar de la formación que tuve. Eh, la salud, eh, generalmente uno veía la medicina por las enfermedades no por la salud... casi todas las patologías; hospitales, patologías, hospitales...como que lo otro lo ignora, así que, eso depende de cada uno...Pero que te incentiven a hacer algo desde la universidad cuando yo estudiaba, no.” (Gabriela)

La implementación cíclica de viejos programas y la ausencia de respuesta de los niveles de decisión política hacia los eternos problemas de la asistencia sostenían la incredulidad sobre las bondades de los mismos:

“¿Sabés la crítica que yo hago al sistema? Que las políticas no son, no tenemos continuidad nunca. ¿Vos sabés las veces que a mí me vinieron a plantear de vuelta el Plan Materno Infantil? ¡A mí me da una gracia!!! porque el Plan Materno Infantil existe hace muchísimos años...y es más o menos el mismo, no hay grandes variantes. Y cada tanto...ahora vas a ver que van a venir de vuelta...y yo los miraba y les decía: ‘Pero eso yo ya lo tengo hace mucho acá. ¿Sabés lo que necesito yo? una asistente social’.” (Gabriela)

2) Con relación a la caracterización y abordaje de la desnutrición, en los pediatras de hospital se manifestaba, respecto de los médicos de los CAPS: mayor ambigüedad en la conceptualización de la desnutrición y de su cadena causal, escaso o nulo conocimiento del entorno del niño, mayor énfasis en características maternas negativas como factor desencadenante de la desnutrición, la afirmación de que ellas

nunca consultaban por el estado nutricional del niño -siempre por patologías-, mayor contraste entre el saber técnico y las prácticas de diagnóstico y tratamiento y carencia de criterios unificados sobre alimentación.

Los médicos de los hospitales y de los CAPS coincidían en la definición de la desnutrición, de sus síntomas, en el tipo de desnutrición prevalente (primaria y leve) que asociaban a carencias socioeconómicas. Todos ellos destacaban la importancia del conocimiento del entorno del niño, de la relación médico-paciente y del diálogo con las madres para afinar el diagnóstico e indicar el tratamiento.

Presentaremos entonces las particularidades de los pediatras que trabajaban en los hospitales y los elementos en común con los de los CAPS.

Ambos definieron a la desnutrición de manera similar, distinguiéndola según su causa en primaria o secundaria.

La conceptualización de la misma, ambiguamente explicitada, cubría un amplio espectro de definiciones técnicas y socioideológicas. Incluía un estatuto biológico de crecimiento inadecuado -e indeseable para quienes ni siquiera pueden expresarla-, a la vez que un conjunto de estereotipos de uso frecuente en la vida cotidiana que integraba representaciones de la desnutrición como problema social, como enfermedad, como trastorno orgánico, como alteración del equilibrio, como descompensación, como deprivación, como patología de la pobreza, como abandono, descuido, anormalidad, etc.

Las definiciones brindadas descubrían los problemas que surgen de la relación entre normalidad, desviación, patología y de cómo los factores “ambientales” y “biológicos” atraviesan esa relación.

“Es un trastorno orgánico y como todo trastorno orgánico se le puede llamar patología...lo que pasa que los ingredientes que llevan a un estado de desnutrición son muy diferentes de alguna otra patología orgánica. El chico está enfermo pero por una deprivación socio-psico-nutricional” (Juan)

“Es un déficit... supongo que es social, alimentario (...). Y sí, es una enfermedad. Yo supongo que debe haber una predisposición ambiental que lleva a ese déficit y...bueno....todas las pa-

tologías que ese chico absorbe y le produce la enfermedad” (María)

La desnutrición remite centralmente, en términos tanto de causalidad estructural como de prevención, a procesos económico-políticos y culturales, por lo cual la capacidad técnica de los médicos para resolverla es restringida.

Así, planteaban su incapacidad para dar soluciones a los problemas nutricionales, persistiendo el enfoque biologicista en la atención de los efectos, aun cuando mostraba limitaciones evidentes.

Si bien reconocían permanentemente que existía una continuidad entre el individuo y su ambiente y una conexión entre la enfermedad del individuo y las enfermedades del grupo de pertenencia, la formación y la organización sanitaria estaban orientadas a la curación individual.

Para explicar las causas, era recurrente la apelación a factores del nivel “micro” y subjetivos (“no saben”) mediante desplazamientos en la cadena causal:

“es de causa primaria, implica mucho la causa social, en la zona son áreas marginales y bueno...no es sólo por el hipoaporte sino por falta de saber utilizar los pocos recursos que a veces brinda el Estado; no saben cómo distribuirlos o hacer bien un aporte para el lactante.” (Martín)

El conocimiento que poseían los pediatras de los hospitales sobre el entorno del niño era limitado o nulo. Pese al escaso tiempo dedicado al interrogatorio, repetían como características de las familias con hijos/as desnutridos una serie de “factores de riesgo”, destacando:

“No, se puede hacer un interrogatorio, ahondar más el interrogatorio. Habitualmente no se hace así de tomar datos de los padres, del tamaño de las familias...o sea que no se sabe nada de la familia.” (Juan)

“Y en general son las madres que tienen más cantidad de chicos. Las familias muy numerosas. Son de nueve chicos, muy numerosas. Y bueno, y es la falta de atención y aparte la falta de trabajo y... son bastante más descuidadas. Hay algunas que no, ojo...” (José)

“La mayoría son madres que tienen más de cuatro hijos eh... y bueno, no saben, son madres

que no tienen la facilidad como para hacer una dieta adecuada (...) capaz que dicen que no tienen pero por ahí tampoco con lo poco que tienen arman un alimento un poco más completo.” (Martín)

La racionalidad y la eficiencia exigidas a aquellos que menos tenían, resultaba a veces sorprendente.

También llamaba la atención el sostenimiento de certezas sobre el peso de algunos “factores de riesgo” incompatibles con otros formulados con la misma fuerza.

Así ejemplo, en lugar del número de hijos, los pediatras de los CAPS, destacaban como factor de riesgo la edad de las madres:

“porque el embarazo adolescente es un factor de riesgo para la desnutrición y tenemos 50% de embarazadas adolescentes, así que son madres.” (Malena)

La consulta espontánea por desnutrición -por demás tardía de acuerdo con el relato- y que correlacionaban con características maternas, era infrecuente en los hospitales, siendo habitual la detección en la consulta por otras patologías:

“En general la población no consulta espontáneamente por desnutrición sino por parasitosis o infecciones banales reiteradas. La mayoría va por una patología aguda, pocos son los que van por control. Las madres lo llevan al hospital porque el chico está enfermo y quieren que le resuelvas en ese momento el problema.” (María)

Los pediatras de los CAPS tenían un registro más matizado sobre la demanda de consulta, también en correspondencia con atributos maternos:

“Pero en general el que viene espontáneamente es el que más rápido sale, porque la mamá es la que está preocupada... esa mamá es la que va a poner las pilas para que aumente el chico. Muchas veces vienen con síntomas visibles, demasiado evidentes... y uno observa, y uno puede sacar un montón de causas de situaciones que pueden estar pasándole a un chico... Una mamá que llega al consultorio y tira al chico sobre la camilla, te está dando una pauta de cómo está viviendo esa maternidad...son datos.” (Ana)

El tratamiento, limitado por la carencia de recursos que afectaba al hospital público consistía en:

“Y ahí, bueno, dándole pautas a la mamá de alimentación. Si está anémico se le da hierro y eso, pero es un problema social. Lo que pasa es que tampoco el hospital tiene alimentos como para darle. Ya te digo, leche hay veces que, bueno, hoy nos quedamos sin leche.” (José)

“El problema socioeconómico no lo vamos a solucionar desde nuestro consultorio... podemos intentar alguna recuperación porque en los hospitales no hay apoyo alimentario.” (Ana)

La representación técnica del “deber hacer” surgía reiteradamente en los pediatras de los hospitales, ocultando la respuesta referida al tratamiento concreto del paciente desnutrido, dado que todos afirmaban la escasez de recursos para poder llevar a cabo las actividades enunciadas:

“El tratamiento de la desnutrición primaria es multifactorial y consiste en la rehabilitación nutricional, la educación a la madres en los cuidados del niño y el apoyo psicológico. Con eso se logra una buena recuperación.” (Martín)

Lo que restaba hacer, y es a lo que todos los médicos entrevistados apuntaban, era:

“Intentar compensar la causa que en ese momento lo está descompensando porque nosotros generalmente lo vemos en agudo. Y bueno, el apoyo orientativo a la mamá con la alimentación. Suplementos alimentarios no tenemos, sí damos suplementos vitamínicos y hierro porque generalmente está acompañado de anemia.” (José)

Respecto de la prevención reconocían que, en su práctica asistencial:

“Lo que pasa es que la forma de prevenir este tipo de trastorno no depende de vos como médico ni de la madre como madre...hay todo un entorno de tipo familiar, comunitario, de la provincia, del país. Es difícil, yo a la madre lo único que le puedo decir es la importancia de la comida, que coma lo que es más útil. Ahora de ahí a que ella lo haga, dedique tiempo a preparar o que el marido traiga el solvente económico para los recursos que uno le indicó... eso ya uno no lo puede...” (Juan)

“No hay nada planificado. En cuanto al tema

desnutrición no hay nada implementado, ni de refuerzos nutricionales o dietas para anemia, no hay nadie que se encargue.” (Ana)

Si esto sucedía en la práctica asistencial, las posibilidades de realizar prevención a nivel poblacional resultaban inviables:

“¡Qué complicado para resolver eso! Es un problema social que el médico no lo puede, lamentablemente...por más que les des la caja de leche... ¿viste?, porque le das la caja de leche a ese, pero se tomaron los seis esa leche, obviamente. Es un drama.” (Juan)

En los médicos de los CAPS se presentaba una mayor correspondencia entre el “deber hacer” y las prácticas. Tenían datos estadísticos sobre el estado nutricional de la población que demandaba asistencia, realizaban habitualmente los controles de salud -sobre todo en los menores de un año-, y afirmaban el cumplimiento de los mismos por parte de las madres así como el de las recomendaciones médicas. Referían una mayor preocupación de las madres por el estado nutricional de su hijo, consultando incluso cuando estaban eutróficos o no tenían signos evidentes de desnutrición. El tiempo dedicado a la atención y a la prevención era mayor y procedían a la derivación al hospital en caso de sospechar alguna patología de base. Presentaban un conocimiento bastante exhaustivo de la población que atendían, reconociendo idiosincrasias según la nacionalidad, adscripción étnica o clase social.

Las distinciones entre grupos y sus características comprendían un amplio abanico de atributos, muchos de ellos estigmatizantes, ubicados en un gradiente que reconocía a los “mejores” dentro de los “peores”, en el que intervenía el cumplimiento como factor ordenador:

“Si bien esta zona es carenciada, hay lugares que son peores. Pero el problema más importante es que la gente es escuchada. Yo creo que tampoco hay que echarle tanto la culpa a que la gente es ignorante. Un ignorante también tiene el mismo derecho a ser escuchado...al que es culto. Y no son dejados, tan dejados como parecen. Yo creo que bueno, hay gente que es muy dejada pero las madres en general tan dejadas no son. Acá vienen, acá cumplen con los controles y con las indicaciones.” (Raúl)

En cuanto a la incidencia de la desnutrición, los datos que manejaban remitían al censo, y todos planteaban que no era un problema que revestía demasiada gravedad:

“Acá se atienden un promedio de 700 consultas mensuales. De los cuales no podría especificar puntualmente el porcentaje. No, cuantificado exactamente no sé, pero desnutridos agudos no hay, son todos límites. Lo más frecuente que se ve que son anemias ferropénicas originadas por parásitos, por parasitosis múltiples...el chico entra ya en el percentilo del tóxico, pero está siempre en el límite. Son chicos que vuelven a caer, y sí, una infección, las infecciones y todo eso lo desnutren cada vez más...” (Gabriela)

“Este... así que bueno, si vos me preguntás si acá hay mucha desnutrición...yo te digo que no. Que hay mal nutrición, sí...porque la base es el hidrato de carbono, eh, los fideos.” (Belén)

Aunque muchos niños no podían ser catalogados como desnutridos, sí reflejaban signos de malnutrición:

“Yo había observado que la contextura de los chicos, de peso aparentemente normal de algunas familias, no de todas...era como más... que la composición era blanda...es decir, lo que se podía llamar el desnutrido farináceo...¿viste?, que era gordito pero que no era un chico, eh, sólido...como que le faltaba musculatura. Le hacés la curva y está bien, pero vos lo mirás y es como que le falta..., bueno, una que hay mucha parasitosis también Eh, mi abuela lo llamaba pelo de hambre, que acá mucha gente cree que es pelo sucio y es pelo de hambre...es pelo de ¿viste?, pajizo, opaco, coloradito, y vos le mirás y decís... porque si vas a ver a donde viven...” (Violeta)

El tipo de desnutrición que atendían era en general leve o de primer grado, los que detectaban de mayor gravedad eran derivados a hospitales por estar asociada a patologías de otro tipo.

Si bien el tipo de atención era “fundamentalmente a demanda de lo que pide la gente”, los controles de salud,

“Sí, se hacen. Sí, hasta el año acá en el centro nuestro es la actividad prevalente. Y durante el primer año las madres cumplen. A los que necesitan les damos leche de vaca, no maternizada

porque maternizadas la Municipalidad a veces compra, pero tenemos a veces un stock de 12 kilos de leche maternizada por mes y a veces pasan dos, tres meses y no tenemos” (Lorenzo)

Luego del año los controles se hacían cada vez más espaciados y la demanda se daba en caso de patologías:

“Y del año a los dos años lo que les digo son controles trimestrales y ya después lo traen cuando tiene una patología. Después de los dos años, bueno, y nos pasa a nosotros con nuestros hijos...y las madres también aprenden. En general charlamos bastante sobre las conductas anticipatorias que uno tiene, que las mamás tienen que tener y que conocer con respecto al manejo de los chicos, sobre todo, bueno, en determinadas patologías...y lo saben...qué sé yo, la dieta para una diarrea...preparar el suero de rehidratación...lo saben, lo saben...” (Lorenzo)

La consulta espontánea por desnutrición incluso se daba cuando no presentaban manifestación orgánica alguna:

“Siempre consultan, muchas veces...consultan espontáneamente por desnutrición no estando el chico desnutrido. Yo te diría que de cuarenta, de treinta y cinco consultas diarias, yo te diría que diez son porque la mamá lo trae porque no quiere comer. La mamá se ocupa mucho de eso. Porque eso...la comida, representa para ella un vínculo, una manera de vincularse con el hijo. Es el primer vínculo con la madre...y a través de la comida es el medio. A mí me pasa eso, a las madres les preocupa el estado nutricional del chico, no sé si a todo el mundo le pasará.” (Susana)

“Sí, les preocupa. Si la madre es normal, sacando las madres que te dije de alto riesgo, todas vienen al control para ver cómo está el peso de su bebé.” (Violeta)

Cabe recordar que el proceso de pauperización evidente en nuestro país en ese momento hizo que familias de clase media empobrecida se volcaran a los servicios públicos de salud, modificando perfil de población que tradicionalmente era atendida. La heterogeneidad de la pobreza complejizó las distinciones entre categorías de familias y pacientes y condujo a acentuar o a establecer nuevas fronteras, sobre el pivote común que define cualidades maternas: cuida/

descuida, atenta/dejada, responsable/irresponsable; culta/ignorante; preocupada/despreocupada. Cualidades éstas que, como se dijo, se definían en gran medida en función del cumplimiento del control.

“Mirá, al centro de salud, por ahí van, para decirlo así en forma global...como dos tipos de, es difícil decir categorías de gente...o de clases....de gente, ¿no?. Pero bueno, están los que son pobres y los nuevos pobres, por decirle a la clase media empobrecida. Por lo tanto las demandas son diferentes ¿no?, o los niveles de exigencia, también son diferentes. No es lo mismo el nivel de exigencia que presenta una familia que entró a la pobreza por estos cambios económicos y una que ya venía de familia de gente pobre. Son muy diferentes... como que unas se sienten preocupadas ¿viste?, las madres se sienten tocadas cuando se les dice que por ahí el chico está desnutrido, ¿no? ...o está bajo de peso, es decir, como que sí, toman en cuenta que es una responsabilidad de ellas por ahí que su chico esté desnutrido.” (Raúl)

Las características de las familias con niños desnutridos tenían que ver con dificultades económicas, desatención, abandono afectivo:

“Un nivel muy bajo, nivel económico muy bajo, hay un pseudo cuidado, ¿viste? En general se da en aquellos chicos, en los de bajo peso, en los que las mamás se despreocupaban... entrecomillalo el despreocupado...porque me los traían acá a los controles: ‘¿Le hiciste los análisis?: ‘Ay, no, no tuve tiempo, tuve que salir a trabajar, no tengo con quien dejar al otro chico ‘...este, ¿viste?, también están limitadas en eso.” (Malena)

“Además...digamos que después de la causa orgánica, como yo digo, parasitosis y a su vez anemia, este... la desnutrición psico-afectiva es una causa también importante ¿sí?” (Gabriela)

“Yo te diría que hay mamás afectuosas, eh, absolutamente, como dicen ahora, maternalizadas; pero depende de cómo fue su historia personal” (Belén)

En la recuperación de la desnutrición, se marginaban los problemas económicos y se destacaba la historia personal y la contención e inte-

gración familiar:

“ahí hubo afecto, hubo también una abuela contenedora, hubo un abuelo que murió que daba un poco de sostén. Hubo como un clan. Yo le doy mucho valor al aspecto, no sé cómo explicarte, al cariño que la gente pone en la crianza. O sea, eso lo veo, lo he visto en el tiempo.” (Violeta)

A las distinciones de clase social, se superponían aquellas que referían a los inmigrantes, cuyas idiosincrasias étnico-nacionales podían leerse en los niños/as.

Uno de los problemas que preocupaba a los pediatras tenía que ver con el desarrollo psicomotriz y psicosocial, sobre todo de aquellos que atendían niños/as de hogares de origen boliviano. Observaban déficits de estimulación del desarrollo infantil en la población boliviana mientras que la desnutrición se daba con mayor frecuencia en los hogares de origen paraguayo:

“Bueno, te digo que mi experiencia acá es de diecinueve años...tenemos muchos migrantes, hay desnutridos en todos los grupos de migrantes, eh...se desnutren más los paraguayos que los bolivianos ¿Viste que los bolivianos vienen de la cultura aymara y tienen una estructura familiar muy sólida, muy rígida? El boliviano por ahí se puede llegar a desnutrir por la parasitosis cuando empieza a caminar, pero son muy buenos lactantes. El problema del boliviano es cuando empieza a caminar porque los hábitos de higiene ¿viste?, que no son muy... son pobres. Y el estímulo es pobre también. En la feria los ponen en cajoncitos... y son esos chicos con cabecitas braquicéfalas, chatitas y están mucho tiempo quietos. Porque ellos aparte cultivan la, eh, cultura...de la quietud. O sea, el chico que se mueve molesta. La falta de estimulación es aterradora, ¿viste?, que lo llevan acá atrás...envuelto, al rayo del sol, ellas están levantando la cosecha y el pibe está en la espalda recibiendo todo el sol, así que por ahí hay algunos deshidratados, ¿viste?, y después la falta de higiene... son todas cosas, bueno, que te llevan mucho trabajo, en el Centro se puede trabajar mucho con eso, sí, si les tenés paciencia.” (Violeta)

Con relación a dicha particularidad, subyace la idea de que la misma es consustancial a la manera de ver el mundo, a no saber vivir de otra forma. Tal argumento, de sostenerse, contribui-

ría a aceptar la esterilidad de políticas orientadas a modificar formas de vida, estructuralmente determinadas, que implican la desigualdad en el acceso a bienes y servicios valorados socialmente y reconocidos como un derecho.

El peso atribuido a ciertas pautas culturales distintivas, no se interpretan en función de condiciones y experiencias de vida. Cabría pensar que ciertas manifestaciones de pasividad, sentimientos de marginalidad, desamparo y dependencia concuerdan frecuentemente con las circunstancias objetivas en que se desenvuelven. Podría pensarse que los pobres, cualquiera sea su idiosincrasia cultural, también suscriben las normas de la clase media, de la sociedad en general, en gran parte de las esferas vitales; después de todo, integramos la misma sociedad.

“La mayoría sí cumple...hay casos, como todo ¿no?, de excepción” (Lorenzo)

El tratamiento indicado a los desnutridos consistía en la dación de leche, alimentos, hierro y suplemento vitamínico, además de recomendaciones a la madre en cuanto a la preparación de alimentos. En ese sentido la intervención médica consistía en enfatizar las ventajas de los comportamientos adecuados y modificar, regular o eliminar comportamientos anormales o desviados. Esto lo hacían a través de las recomendaciones alimentarias, la insistencia en los controles de salud, la promoción de hábitos alimentarios y de higiene, etc.

Asimismo, el tratamiento antiparasitario contribuía sustancialmente a mejorar el estado nutricional:

“Los chicos que son tratados con el tratamiento antiparasitario es espectacular cómo mejoran en peso...los chicos tienen otra actitud frente a la comida, comen más, ¿eh?” (Gabriela)

Respecto de la eficacia del tratamiento, hay quienes reconocían limitaciones y gran frustración:

“A veces, ¿viste?...te das contra la pared diciendo: ‘hasta acá llegó mi amor’...porque realmente...se hace difícil. Es limitado, sí, sí.” (Raúl)

“Se puede llegar a ayudar en forma de hacerle más controles seguidos, tratar de que se enferme menos, de conseguirle medianamente -si se puede- algo de lo que necesita. Pero son pro-

blemáticas muy duras y muy difíciles de resolver.” (Eduardo)

Las actividades preventivas se limitaban a recomendaciones durante la consulta propiciando conductas anticipatorias y umbrales de demanda oportunos:

“La tarea preventiva, la hacemos un poco en el consultorio, no tenemos posibilidad de salida al exterior, no hay asistente social.” (Susana)

En lo que hace al cumplimiento de las recomendaciones médicas opinaban que:

“La mayoría sí cumple...hay casos, como todo, ¿no?, de excepción, pero generalmente lo que, estos casos de excepción son porque hay una problemática social muy grave de trabajo...que por más que hagas lo que hagas ese chico está, por la problemática social está ya jugado, ¿no?...y es muy difícil de revertirlo en el centro de salud, cosas muy groseras, muy fuertes y que escapan a uno...eso no podés llegar a resolver nada, es todo el entorno social que vive, ¿no?” (Lorenzo)

“En general ¿viste?, el manejo de la alimentación corre mucho más por el bolsillo del grupo familiar que por la indicación que uno pueda llegar a darle.” (Malena)

“Mirá, en general están bastante informados... aunque a veces te llevás algunas sorpresas tristes.” (Gabriela)

Finalmente, un dato que algunos pediatras destacaban -debido al énfasis puesto en la promoción de la lactancia para prevenir la desnutrición- era su prolongada duración:

“Pero en general las mamás les dan de mamar y a veces en demasía, o sea, habitualmente sucede al revés, yo creo que sucede más que nada por la prolongación de la lactancia que por el poco tiempo. La lactancia, más allá de los ocho meses, o sea, al prolongarse la lactancia, el chico comienza a desnutrirse, porque el chico que toma la teta no toma leche de vaca y no come. Y ya tiene una edad como para, este, necesita más calorías para crecer. Entonces no crece, empieza a anemizarse, la anemia origina menos apetito, es un círculo.” (Violeta)

Asistir a personas cuya salud se juega en otros campos, desalentaba y mostraba la limitada capacidad resolutoria:

“Esa es mi experiencia, de cualquier manera es bastante, en algún aspecto es un poquito desalentadora, ubicate en mi realidad, que uno cree cuando viene acá cree que con lo que viene a traer le va a ayudar a la gente a resolver sus problemas. Tenés que aprender que el problema del chico lo resuelve la familia...y con las potencialidades que tiene. Por ahí el médico puede ayudarles a hacerles ver esas potencialidades...” (Malena)

Pero la tarea pedagógica desplegada en las consultas de los CAPS, a menudo tampoco daba resultados auspiciosos. En esos casos, si bien percibían que los consejos habían caído en saco roto, constataban a la vez que pese a lo que consideraban enormes transgresiones, los chicos igual sobrevivían:

“Un día me sentí defraudada porque atendí el tercer hijo de una paciente mía y yo le digo: ‘¿Qué le das de comer?’, tres meses, ‘Come con nosotros’, yo ya me empecé a...le daba de todo. Tenía tres meses y le daba de todo...le daba los guisos completos, le daba, faltó que le diera vino...Y ella tenía más chicos y yo se los había atendido a todos. O sea dije: estos no entendieron nada, ¿para qué hablé?, hablé de gusto. No hablo más. Sobrevivieron igual todos. También pienso en eso, sobrevivieron. No, pero era mucho, ¿eh? te digo que era mucho.” (Violeta)

En estos casos, los esquemas clasificatorios, en función de las respuestas de las madres a las actitudes compasivas de los médicos, se ligaban a sentidos sobre “merecedores” y “no merecedores” de asistencia.

En otros casos, los problemas de comunicación y las quejas de algunos médicos sobre las brechas comunicativas, resultaban incluso paradójicas. Tal es el caso de la omisión por parte de muchas mujeres, de informarles a los médicos que tomaban pastillas anticonceptivas cuando se les consultaba sobre el consumo de medicamentos¹⁰. La confrontación de dominios semánticos descubría, en todo caso, que el significado

¹⁰ Se trata de situaciones planteadas por médicos generalistas de CAPS, en conversaciones informales durante el trabajo de campo del estudio que estoy comentando y de otro realizado en 2005 sobre maternidad adolescente.

de “sentido común” de las pacientes respondía a la definición canónica ¹¹.

3) La última dimensión de análisis de las entrevistas, es la que contiene la apreciación de los médicos sobre la receptividad y respuestas de las madres en la atención del hijo/a desnutrido, sobre los cuidados y sobre el uso de medicinas alternativas.

Con relación a esto, las diferencias se observaban en que -comparativamente con los pediatras de los CAPS-, los pediatras del hospital consideraban que las madres carecían de signos de alarma, ellos sobredimensionaban la utilización de medicinas alternativas, las estigmatizaban en mayor medida, y la eficacia que atribuían a las mismas estaba basada en principios y entidades reconocidas por la medicina científica (la cura coincide con la evolución natural de las virosis). Los pediatras de los CAPS reflejaban un mayor conocimiento de la medicina “popular” y reconocían los principios activos de los “yuyos” y de los mecanismos fisiológicos que desencadenaban ciertas prácticas curativas. Asimismo señalaban no tanto la oposición sino más bien la complementariedad de ambas formas de atención.

Las consideraciones similares en ambos grupos se relacionaban con la visión de los médicos acerca de la reacción materna -de preocupación y no de alarma- frente al diagnóstico de desnutrición y sobre la negación, por parte de las madres, de limitaciones económicas familiares que imposibilitaban una adecuada alimentación, estando presente en esta negación el estigma con el que la madre debía cargar. Para las madres, de acuerdo con la apreciación de los pediatras entrevistados, la desnutrición era el resultado de alguna patología o de la “pata de cabra” y la mayoría de ellas respondía de manera satisfactoria a las recomendaciones médicas.

Todos los entrevistados conocían el uso de la medicina popular por parte de sus pacientes y adoptaban una actitud de “respeto” con adver-

tencias sobre los riesgos de intoxicación con té de “yuyos”. Planteaban la dificultad de modificar o alterar dichas prácticas y creencias ya que formaban parte de “su” cultura y en general, las ubicaban en el campo de lo sobrenatural, de la magia o de la superstición.

Acordaban que las respuestas maternas frente al diagnóstico imprevisto no evidenciaba alarma aunque sí preocupación.

“Cuando les digo a las madres que su hijo está desnutrido ...se preocupan.” (Eduardo)

Esta actitud, mayoritaria, resultaba sin embargo más evidente en aquellas cuyos hijos no presentaban mayores problemas o bien las que respondían exitosamente al tratamiento, habiendo casos que no manifiestan preocupación:

“Algunas, las que no se tienen que preocupar... se preocupan porque la abuela les dice que el chico está flaquito...entonces venís, lo traés, lo pesás, lo medís y está dentro del percentilo normal...percentilo 50, bárbaro, le digo: ‘no, quedate tranquila’, porque la abuela, la suegra le dijo...y no, está bien. Y las que son desnutridos, a esas no les preocupa.” (Malena)

“No,...no, hay muchas que no se hacen problema. Hay otra por ejemplo como la que está hoy citada, que viene acá, este, sí, estaba re- preocupada.” (María)

La apreciación sobre las respuestas de las madres ante el diagnóstico de desnutrición reflejaba, en virtud de los comentarios de los pediatras, la gravitación de la culpa.

El estigma asociado al término desnutrido era compartido por las madres a quienes les incomodaba tal etiquetamiento:

“Hay otras como que se sienten heridas digamos. Porque es como que es culpa de ellas. Este... y es medio como que no les gusta.” (Ana)

“No les vayas a mencionar distrófico ni desnutrido porque les choca. Si les decís está flaquito ya es distinto y vos en definitiva querés expresar lo mismo. Porque ya viene con la idea de que es maltrato hacia el chico o porque evidencian el trastorno económico.” (Juan)

De allí que muchos optaban por un cambio en la terminología:

“Le dije que era bajo peso; le cambié el nombre.

¹¹ “Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta” <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=OkIjC3R>; “sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico”; etc. Ver también http://www.who.int/topics/essential_medicines/es/; <http://www.anmat.gov.ar/webanmat/consumidores/faq.asp#>.

Porque con esa mamá yo la palabra desnutrido no la puedo usar. La pauperización la hace sentir muy mal, por eso, sin embargo ella sí tiene nivel de alarma.” (Raúl)

Según los médicos, prevalecía en las madres una actitud de negación de problemáticas económicas o de alimentación familiar; y las reacciones de ellas frente al diagnóstico dependían de la edad del niño, de la gravedad de su estado nutricional, y de la presencia de patologías:

“Los que llegan con patología y con un déficit de primer grado, esos, jamás la madre piensa que está bajo de peso, dice que come bien.... bueno, medio que lo niegan. Pero a veces también se preocupan mucho y ahí empiezan a dar bolilla y responden bien.” (Martín)

“Les sorprende el diagnóstico ‘porque el nene come bien’. Otras lo aceptan como algo factible: ‘me parecía que estaba flaquito’, ‘me come poco’. En general después de varias charlas entienden el diagnóstico y cumplen las indicaciones en la medida de sus posibilidades económicas.” (María)

Asimismo, planteaban que para la mayoría de las madres, la desnutrición no era una enfermedad:

“La gente no considera a la desnutrición como una enfermedad en sí misma. Muchas veces hacen referencia a la desnutrición como una consecuencia de infecciones. Otras veces señalan que todos los hermanos son flaquitos y ese también. (...) Que es porque está enfermo el chico, que no es culpa de ellas... y algo que le busque yo...porque el chico tiene algo que por eso no engorda. Entonces, este... tratan de desligar.” (Martín)

“Que se enferman muchas veces y eso los hace bajar de peso, que le tocan más las diarreas o el mal tratamiento de la enfermedad, ya que se reitera siempre lo mismo.” (Juan)

La demanda espontánea por bajo peso se daba en casos de suma gravedad: “los signos de alarma no los tienen”. Contradiciendo su apreciación acerca de la importancia de la comunicación con la madre, de la explicación de la enfermedad y de los cuidados maternos hacia el niño, a esta pediatra le preocupaba que las madres supieran

reconocer los signos de la desnutrición, no sus causas y menos aún la forma de resolverla argumentando que “para eso estamos nosotros”:

“yo quiero creer que la gente tiene que creer que es una enfermedad más, un trastorno, que debe ser atendida y que no tiene por qué saber por qué su hijo está desnutrido porque para eso estamos nosotros. Yo lo que necesito como médico es que se den cuenta de que algo alrededor de su hijo está pasando, después somos nosotros los que nos tenemos que encargar.” (María)

Si bien casi todos solían reconocer la importancia del autocuidado y la autoatención en las recomendaciones terapéuticas, lo hacían de forma instrumental, en el mejor de los casos orientada por el «sentido común» del médico; como coadyuvante del tratamiento. Desde la medicina el reconocimiento de este campo era generalmente reducido a su posible incidencia en la llamada «adherencia» o «cumplimiento terapéutico”.

Los médicos entrevistados planteaban, con relación al uso de medicinas populares, una actitud de respeto “siempre y cuando no sea nocivo:

“Soy respetuosa porque creo que es toda una manera de expresar la cultura. Por eso dije, que en el caso de los tés, o sea, hay algunas situaciones que no...o sea, siempre y cuando no sea nocivo, no le haga daño, sí.” (Belén)

“Sí, ellas me cuentan que lo mandan, pero no son la mayoría, no, para nada. Y cuando me cuentan no les digo nada. Es respetar al otro. Yo sé cómo ellos piensan y es como ponerse en el lugar del otro....y bueno, entender que ellos, este, tienen ese razonamiento y bueno...y esa es su interpretación. Yo no la voy a cambiar. Lo que sí es que hay que advertirles, claro, en cuanto al uso de tés. O sea, todo lo que es la intoxicación folklórica, que es re-frecuente que cuando está con diarrea todas las mamás le dan algún té: de manzanilla, yerba de pollo, poleo, qué sé yo.” (Lorenzo)

Las prácticas de atención ponían de relieve que lo cultural, en tanto diferencia, representaba un obstáculo a las normas y prácticas sanitarias instituidas, valorándose su recuperación para mantener el control.

La reproducción de los saberes adquiridos y la falta de actualización de nuevos saberes obliga-

ban a los médicos a refugiarse en el terreno de lo conocido y a condenar aquello que en realidad desconocían o conocían fragmentariamente.

“Yo no tengo experiencia con la medicina folklórica porque estoy formado para usar otro tipo de medicina. Se dicen muchas cosas de un lado, en la parte profesional, y se dicen cosas del lado del paciente. Es cierto que muchas cosas que toman son tóxicas, incluso los chicos corren riesgo de vida en los primeros meses sobre todo. Pero también gente que ha hecho experiencias en comunidades donde ha trabajado y manejado medicaciones a base de hierbas, se sabe que tienen beneficios. Entonces yo lo único que le digo a la gente...cada uno es respetuoso de tener la creencia que tenga. Yo estoy obligado a informarle lo que conozco de cada yuyito, de cada hierba y recomendarle lo que no le conviene hacer. Un paico al mes de vida puede llegar a ser mortal.” (Juan)

La utilización de infusiones caseras y la consulta a curanderos formaba parte del conjunto de atributos intrínsecos y extensivos a toda la población pobre.

“Yo te digo, yo pienso que es más cultural que otra cosa, por eso se mantiene, se da más en la gente de más bajo nivel socio-cultural”.(Juan)

“Usan yuyos, té de yuyos en cantidad. De todo, hasta orégano, de todo. Tenemos cualquier cantidad de esa medicina folklórica, cualquier cantidad...de todo, paico... y tenemos un cartelón así en la pared incluso, cada cosa lo que provoca, para qué lo dan habitualmente y qué es lo que hace y este..., no, pero y muchas lo niegan. Pero sí, sí, le dan. Hay muchísimos casos de intoxicación, chiquititos, ¿eh?... paico, poleo son los más comunes. Pero hasta orégano he escuchado. Que según dicen...la que llega al orégano es porque ya le dio todo.” (María)

El respeto hacia dichas prácticas estaba condicionado a su uso complementario y subalterno respecto de la medicina científica, tratándose de una declaración formal y relativa al tipo de tratamiento:

“Los tratamientos populares pueden ser aceptados por la medicina mientras no interfieran con ella. En la medida en que no retrasen los diagnósticos o interfieran con el tratamiento

médico indicado o dañen la salud como la intoxicación folklórica, no se realizan mayores recomendaciones.” (Martín)

“Que mientras que no les dé de tomar algo, té o algo que sea ingerir, que sea de palabra o pasarles un talco sí, nada que absorba por piel...que lo lleven pero siempre ahí junto con la consulta del médico ¿eh? (...) Porque tienen muchas creencias, hay muchos que están muy aferrados. Tienen fe en las palabras y bueno, es su forma de expresar de tratar de ayudar al chico de su parte.” (Juan)

El médico intentaba captar la confianza de la madre a fin de asegurar mayor control del caso, alarmando acerca de los efectos iatrogénicos que podían provocar:

“Con los pacientes se habla sobre el tema. Es más y es como que cuando hablamos alarmamos sobre las contraindicaciones, sobre los efectos, digamos, y como que se los hacemos..... peor de lo que son. Que realmente te digo, han llegado algunos y se han muerto. Generalmente les digo que no les den nada de tomar y que me cuenten. (...) Yo creo que las mamás con esos tratamientos se deben sentir más contenidas... es como parte de ellas ¿no? Yo les digo que tienen que ir a las dos cosas paralelas.” (José)

La actitud neutral -al menos aparente y provisoria- obedecía a la necesidad de conocer qué otro tratamiento estaba recibiendo el niño para poder evaluar su estado y evolución:

“Nunca le contradigo cuando me dicen que van al curandero, más vale escucho Aunque me dice que le está dando un yuyito, algo, escucho y espero que siga contando a ver qué más está haciendo, ¿no? Es una forma de acercarme...pero no, trato de, de por lo menos no contradecir lo que es curar el empacho, curar la pata de cabra, eh, no le aconsejo que vayan pero tampoco le digo que no vayan. Las madres me comentan que van, sí, sí, es muy frecuente. Y por lo menos, con esas creencias no, no podés, es como la religión, ¿no?” (Lorenzo)

De acuerdo con los testimonios de los entrevistados, las creencias populares se mantenían no solo por hallarse enraizadas en “su” cultura sino también por desconfianza hacia la medicina científica:

“Pienso que esos tratamientos se dan cuando la gente no tiene completa confianza en la medicina y también porque están muy arraigados en la población”. (Martín)

El efecto negativo atribuido por la mayor parte de los entrevistados a las prácticas de automedicación, hacía pensar sobre la existencia de amplios conjuntos sociales comprometidos con la irracionalidad, que de manera vacua o aun con efectos perjudiciales, apelaban a recursos terapéuticos alternativos debido a automatismos propios de la “herencia cultural” de la “cultura de la pobreza”:

“No sirven para nada. Yo creo que es un problema cultural, por eso siguen. Se lo van diciendo de madre a hija: ‘...porque yo te daba y si le das un poquito’, y... así, se transmite.” (María)

La pregunta pendiente que se impone, dada la habitualidad que según los médicos tenían tales prácticas y su potencial gravedad, es: ¿por qué no se mueren más o hay más registros de intoxicación por intoxicación “folklórica”?¹²

Por otra parte, la eficacia que algunos médicos asignaban a los tratamientos populares estaba fundada en la historia natural de la enfermedad:

“Lo que pasa que cuando se cura, que piensan que es por el curandero coincide con la evolución de la enfermedad, entonces generalmente coincide con eso: se terminó la virosis.” (Ana)

Otros destacaban la eficacia pragmática de los tratamientos populares, habiendo leído acerca de ellas, conocido y experimentado algunas de las prácticas de uso frecuente:

“Ojo, hay que informarse hay que leer, pero en la medicina que me formé yo no figuraban. Hoy la OMS está saliendo a reconocer como productos útiles a ciertas hierbas. En este momento no recuerdo cuáles son.” (María)

“Sí, el doctor Gianantonio me enseñó a tirar el cuero. Mi mamá me enseñó a mí...y le enseñó, te

estoy hablando del doctor Gianantonio...eh, él fue el que le enseñó a tirar el cuero...o sea, existe la explicación fisiológica. No, y los yuyos también, digamos, aparte se confunde, yo a veces digo, bueno...el problema es de osmolaridad. Sí, y por ahí...o se deshidratan.... Por ahí no el yuyo en sí, pero sino la cantidad...Cuando son chiquitos sí, se mueren, ese tipo de convulsiones...el desequilibrio es muy grande. La hidratación en los chicos de menos de un año, el balance del agua...es muy delicado.” (Gabriela)

Una de las entrevistadas, a raíz de su experiencia profesional y de una investigación realizada con plantas medicinales comentaba que:

“había empezado a hacer un relevamiento porque yo tenía la hipótesis que se confirmó...se confirmó pero no lo pudimos hacer bien...de que no eran tan tóxicas las sustancias...”

No son tóxicas. Yo relevé, ya te digo, doscientos casos, me llegaron a traer, tenía lleno de paico, yo no las conocía...de todo. El caso más simpático es una chica que me mencionó diez yuyos. Cuando terminó, me había dado, habíamos confeccionado una planilla donde decía, bueno, formas de administración, dosis, eh, para qué lo daban, o sea, posología, todo...

Yo tenía con nombre y apellido, familias...O sea, eso volcado a datos concretos.

Las familias cómo le daban al adulto, cómo le daban a los chicos, cómo los preparaban...

De todos los casos, si no me mintieron, hubo un solo caso que la mamá reconoció una intoxicación...y el caso más gracioso fue una abuela, la chica esta que le digo: ‘¿Cómo sabés tanto de yuyos?’ ‘Mi abuela me enseñó’, ‘¿Y tu abuela vive?’ le digo, ‘Sí’, me dijo. ‘¿Y qué edad tiene?’ ‘104 años’. Yo dije: ‘Dame los yuyos’.

Pero bueno, yo creo que con todo hay que hacer un equilibrio. Yo trato de que si veo, primero trato que no lo tomen los bebés chiquitos, porque acá hay mucha gente que hace cocimiento...no es lo mismo que infusión...y el cocimiento sí intoxica...

Pero yo recuerdo acá, van a hacer diecinueve, veinte años que estoy acá...intoxicados por yuyos vi un solo caso. Yo les trato de que no lo hagan porque son muchas cosas después para valorar en la evolución del chico...pero el empaño, la cintitas rojas...los collares con dientes de perro...sí.” (Violeta)

¹² La información disponible indica que la intoxicación medicamentosa en los niños se da predominantemente por remedios de patente, cuya venta libre se incrementó casi 300% entre 2000 y 2016. Por problemas de espacio omito las referencias y recomiendo un informe reciente: http://www.ieps.com.ar/es/informes/Revis-ta-IEPS_2015-05.pdf

La ambigüedad respecto de las otras formas de atención operaba de manera selectiva y oportunista, pues mientras que los cuidados y la autoatención eran de modo intermitente reconocidos y convocados como formas complementarias de la atención profesional, comúnmente solían ser consideradas por ellos como negativas por más que las declarasen decisivas en la resolución de los problemas de salud, especialmente cuando apelaban a medicinas alternativas.

El problema de la automedicación y de las medicinas alternativas, restringido por parte de todos los entrevistados al campo de la medicina folklórica en sectores bajos, aparecía finalmente como problema y se abría como espacio de reflexión también para el caso de la medicina científica y de sus respectivas eficacias:

“Ese es un tema grandísimo, el tema de la automedicación...el tema de creer de que a través de esas hierbas hacen milagros...el único que hace milagros es Dios. Para responderte tendríamos que hablar de creencias culturales, de lo que la gente piensa de por qué el sistema permite que la gente vaya y compre medicamentos. (...) Y con la masificación de la medicina como se está produciendo, de la atención médica masificada cada día van a pulular más esos tratamientos alternativos. Antes si vos ibas a ver a un médico clínico se tomaba 45 minutos, en este momento no sé cuántos médicos hacen eso. Y no sé, por la falta de tiempo, cuántos diagnósticos se pueden estar escapando por la forma en que yo puedo atender o en general los médicos pueden estar atendiendo en ese momento. Si van cien personas a un lugar a consultar, de esas cien se curaron cincuenta y quedaron otras cincuenta sin respuesta. Y en los hospitales ni hablemos, la posibilidad de solucionar esos problemas son cada vez menores. Y la gente necesita soluciones y las va a ir... va a recurrir y la gente, la gente en general, el ser humano, por una cuestión de instinto de salvación...va a buscar las soluciones donde sea.” (Juan)

Desde sus categorías conceptuales, este médico hacía referencia mediante su idea de “instinto de salvación” al proceso de autoatención -desarrollado anteriormente- en tanto modelo de cuidado y atención estructural de los individuos y de los microgrupos.

Respecto de la “pata de cabra”, enfermedad

ampliamente conocida en las familias de sectores pobres que cae bajo la órbita de atención de la medicina popular y que se relaciona frecuentemente con un estado de desnutrición (Ortale y Rodrigo, 1997) los pediatras planteaban:

“La pata de cabra es una fábula que todo el mundo la cree. Y que te la cuentan, yo la aprendí acá, nunca la había escuchado, es algo muy mágico, ¿viste?... es como una fantasía...es como que va subiendo, dicen, por el espinazo y que llega a la zona de acá...algo yo escuché del bicho, del gusano...ponen mucha magia en eso.” (Belén)

“no lo relacionan con que tenga alguna enfermedad sino que tienen algo de esto que para ellos es enfermedad a su manera. Dicen que no aumentó porque tenía la pata de cabra...pero cuando uno les pregunta puntualmente.” (Juan)

Esta situación no era ocultada por las madres quienes la comentaban al médico siempre y cuando el mismo se interesara por el tema:

“Sí, ellos hablan de la pata de cabra. Y lo comentan...sí, y te dicen que lo llevan al curandero... No sé a la pata de cabra qué le dan pero en general los frotran...” (José)

“Muchos lo curan de palabra o le pasan algo en la espaldita. Las madres no lo ocultan que fueron, me lo dicen, siempre asocian al hijo flaquito con la pata de cabra. A veces el mismo curandero también lo manda al médico.” (Juan)

No está de más señalar que los tratamientos alternativos se dan simultáneamente o alternadamente con la asistencia a la medicina formal:

“... acá igual vienen solitos, ¿eh?. Yo no sé si el curandero, este, les dice vayan al pediatra, eh, pero vienen. Yo creo que se quedan más conformes... sí, más tranquilos. Le hicieron la terapia alternativa...y por las dudas que no tenga alguna otra cosa vienen el día de la atención.” (Eduardo)

Más allá de las particularidades de los entrevistados, cuyas diferencias según su ámbito de trabajo se registraron en las prácticas y sus coincidencias en las manifestaciones sobre el “deber ser” o el “deber hacer”, de lo expuesto se pueden abstraer algunas expresiones de la bio-

medicina, a saber:

Una representación abstracta y homogénea de sus saberes, en ocasiones orientada por la ilusión de que ciencia y verdad se confunden.

El centramiento en aspectos orgánicos, produciendo una tensión entre el saber derivado del modelo científico (un saber sobre el organismo, sobre las enfermedades), y el sentir (expresado en las prácticas cotidianas de los médicos asistenciales que interactúan con los pacientes).

La pretensión de una mirada objetiva de los problemas que atiende, la que promueve el desplazamiento de factores esenciales relacionados con su práctica.

Un enfoque reduccionista de los procesos culturales implicados en la salud/enfermedad/atención.

Identificación con la función curativa, pese a la relevancia de la normatización y control.

Eficiencia diagnóstica y eficacia terapéutica como elementos centrales que explican su preeminencia respecto de otras formas o sistemas de atención

La extensión de su campo de competencia e intervención a problemas sobre los cuales su eficacia terapéutica es limitada o nula, desempeñando funciones de control y normatización de comportamientos que inciden en la salud.

La paradoja de la medicalización, que a la vez que establece un distanciamiento respecto de los saberes y prácticas no científicas o “legas”, al mismo tiempo implica articular con ellas; requiriendo mínimas correspondencias o correlaciones entre ambos tipos de saberes. El saber médico, para actuar eficazmente, para servir como cura y control, necesita funcionar en un espacio cultural y social compartido o común de reconocimiento.

La importancia de la relación médico/paciente como espacio en donde: se da la articulación de saberes, se sostiene y legitima el modelo de atención, y se generan nuevos conocimientos científicos.

La estructura asimétrica de dicha relación derivada de que el conocimiento genera poder¹³. La posición subordinada del paciente en su relación con el médico involucra una necesaria enseñanza (la prescripción médica) y una necesaria apropiación (cumplir dicha prescripción).

Espacios mínimos dedicados al conocimiento

de los enfermos, pese a las declaraciones sobre la importancia de la escucha y de comprender la subjetividad de los pacientes.

Posición ambivalente respecto de la autoatención (se reclama y se condena).

Lo cultural está en los “otros” y se percibe como obstáculo, resistencia o barrera a normas y prácticas sanitarias instituidas.

La descalificación de prácticas ajenas a su dominio, por más que algunos médicos incorporen -no sólo en su vida privada-, nociones y recursos de medicinas alternativas, tal como se constata con la “medicina holística”.

La recuperación de otros saberes y la identificación de otras formas de atención se realizan, la mayoría de las veces, con fines instrumentales.

Ahora bien, estos rasgos se complejizan al estar acompañados de otras evidencias: la influencia de factores socioculturales e institucionales de naturaleza extra científica en el proceso de atención; las condiciones de trabajo; los salarios, el reconocimiento a su tarea; la gravitación de la biomedicina en la creación de renovadas “concepciones populares”; la apropiación simplificada y esquemática de los saberes biomédicos por parte de los pacientes; la adhesión, interferencias, modificaciones de los cuidados o de la atención de la enfermedad a partir de tales apropiaciones; el carácter abierto, dinámico y coyuntural de los saberes y recursos puestos en juego en la atención; la apelación a otros sistemas de atención cuando no se producen las articulaciones o correlaciones entre los saberes “legos” y los saberes biomédicos o cuando ellas pierden inteligibilidad; las resistencias y contradicciones presentes en la atención: los problemas de cumplimiento en los tratamientos, la negociación de alianzas terapéuticas con los pacientes; la elaboración de estereotipos sobre los pacientes, los hogares y las comunidades para resolver el fragmentario conocimiento acerca de ellos; intentar soluciones en el ámbito de la edu-

enlaza a un conflicto en el sentido o de una división de intereses o de una lucha activa; el poder no es intrínsecamente opresor. El poder es la capacidad de alcanzar resultados; que éstos se relacionen con intereses puramente sectoriales no es esencial a su definición. Como tal, el poder no es un obstáculo a la libertad o a la emancipación sino que es su verdadero instrumento, aunque sería insensato desde luego, desconocer sus propiedades coercitivas. La existencia de un poder presupone estructuras de dominación por las cuales opere un poder que «fluya parejamente» en procesos de reproducción social (y que sea, en cierto modo, «invisible»). La manifestación de fuerza o su amenaza no es el caso típico del uso del poder.

13 Retomando a Giddens (1995), el poder no necesariamente se

cación para la salud, entre otras.

Y con relación a ellas, los médicos se desenvuelven solitariamente, con nulo o mínimo respaldo científico e institucional.

No se trata de cuestionar a los médicos, a su ardua labor y a sus buenas intenciones. Interesa destacar un conjunto de elementos presentes en la atención, que están por fuera del modelo biomédico (incluso en su manifestación en el trabajo asistencial); cuánto interviene aquello que excede a su dominio (circunscripto a tratar signos y síntomas propios de cada enfermedad o padecimiento). Tal “desajuste” no constituye una excepción; pone de relieve las carencias y limitaciones de la biomedicina para tratar efectivamente los problemas de los pacientes, problemas que remiten -entre otras variables- a condiciones de vida, claramente inherentes a la posición social en el caso analizado.

En él, el agente patógeno como factor explicativo constituye un débil recurso o su alcance es limitado. De allí la necesidad de lograr una actitud colaborativa por parte de las madres u otros familiares, ya que caso contrario, todos los esfuerzos serían inútiles. Y es aquí en donde juega la atribución de responsabilidades en lo que respecta al origen y mantenimiento del padecimiento, proceso que adquiere enorme relevancia en la generación de estigmas y sentimientos de culpa.

A la vez, se podría pensar que esta débil vinculación con agentes patógenos, o su inexistencia, favorecería disociar el padecimiento de la competencia biomédica y con ello, que los pacientes cuestionen o rechacen sus intervenciones, recurriendo a otras formas de entender el trastorno, sus causas y su sintomatología.

Conclusiones

Asumimos que, en distinto grado y con distintos sentidos, existen principios generales y compartidos por las disciplinas que tratan con problemas humanos: la unidad biopsicosocial del hombre y el carácter sociocultural de los procesos de salud/enfermedad/atención (en sus manifestaciones epidemiológicas y en sus definiciones y abordajes).

En este capítulo, con base en la presentación de las formas en que las ciencias antropológicas y médicas incorporan esos reconocimientos, se quiso señalar que hay mucho en los manua-

les de la primera que continúan como campos inexplorados y que la segunda, desvalida de herramientas acordes a tales principios, trata cotidianamente con realidades que dan cuenta de ellos, y esas realidades que se le imponen no entran en sus manuales.

Pese al ropaje científico, no somos observadores o interlocutores neutrales. Sin embargo, es evidente la tendencia a utilizar el propio conocimiento y a revestir/encubrir la propia cultura con un traje “universal” y “culturalmente invisible” cuando interactuamos con “otros” y los interpretamos (Rosaldo, 1991).

El extravío de pensarnos culturalmente “invisibles” fue resultado, paradójicamente, de cierta antropología que fusionó la noción de cultura con la idea de diferencia, con modos de vida contrastantes¹⁴. Los efectos de tal noción, ampliamente cuestionada dentro de la propia disciplina desde hace al menos 35 años, hicieron que dentro de la propia sociedad, la gente “con” cultura fuese aquella que reside en zonas marginales, que se encuentra en la escala más baja de la estructura social. Por tanto, cabe que interpretemos sus diferencias culturales como señales de subordinación dentro de la sociedad global, derivadas del desigual acceso a los recursos valorados socialmente.

Por lo general, y aunque se declare el “respeto” por la cultura del otro, las nociones de “diversidad cultural” o “diferencia cultural” con las que se pretende resolver las dificultades en la atención o en el tratamiento, tienen resabios de “sos distinto pero te perdono”. En el mejor de los casos, su uso se convierte en un terreno neutral, de aparente consenso que no refleja la variedad de procesos de etiquetamiento y de interpretaciones que se solapan o enmascaran.

Por su parte, en la Antropología, la supuesta omnipresencia y gravitación de la cultura se observa en su utilización sobre determinados procesos micro sociales, referidos particularmente a los aspectos simbólicos y a la diferencia.

Ahora bien, sabemos que la salud depende de múltiples factores y actividades que no siempre parecen estar directamente relacionadas a ella; comprende múltiples acciones cotidianas que son significativas para la salud pero que no son necesariamente médicas.

¹⁴ Esa noción aún está presente en quienes asocian la Antropología Cultural con el estudio de los pueblos indígenas y sus modos de vida, idea por cierto bastante generalizada.

Sabemos también que cualquier sistema médico profesional (biomédico, homeopático, “tradicional”, etc.) requiere del dominio de saberes y habilidades para cuidar y atender la salud, pero que los individuos y hogares, pueden prescindir de ellos. Con esto se pretende destacar un aspecto obvio: que la salud/enfermedad y habitualmente también la atención, se inician fuera del sistema médico profesional y que, en buena medida, se resuelve fuera del mismo (Haro Encinas, 2000). Los saberes “legos” constituyen un sustrato siempre presente, determinante para la salud y determinado a la vez por las condiciones en que se organiza el modo de vida de individuos y grupos sociales.

Ellos, bajo las formas de autocuidado y autoatención, involucran generalmente a las redes sociales (familia extensa, relaciones de amistad, compadrazgo, vecindad, laborales, de estudio, etc.) que brindan asistencia en caso de enfermedad o ante cualquier aflicción. Tales redes naturales de ayuda, no se organizan explícitamente para tal función. Forman parte de los mecanismos universales de reciprocidad que están en la base de la vida sociedad: dar ayuda a quien la necesite para a la vez recibirla en casos pertinentes, estableciendo un marco de obligaciones y derechos. De ello se desprende que los procesos asistenciales, cualquiera sean, involucran no solo elementos técnicos, sino también sociales, culturales y morales, que definen las formas que adopta la asistencia.

Sin embargo, la salud parecería ser monopolio de los especialistas (cualquiera sea la sociedad y su sistema médico). Y este monopolio, en el caso de la biomedicina, ha tenido costos no sólo económicos sino también en términos de la baja eficacia para resolver numerosos problemas y de frustraciones profesionales.

Pese a la importancia de la autoatención y a que el sistema biomédico contribuye decisivamente en la definición de sus modalidades y contenidos, las actitudes con relación a ellas que ha promovido son ambiguas, lo mismo que con relación a otras formas de atención por fuera de la prescripción médica. Ha sido relativamente tolerada y en ciertos contextos incluso fomentada; ello ha sucedido por ejemplo con la automedicación responsable en los países desarrollados que consideran a la automedicación con remedios de patente de venta libre como una solución para mejorar el acceso a la salud, en es-

pecial, en condiciones de adversidad económica. Lo mismo con relación al comercio de la herbolaria, que se ha liberalizado en países en donde estaba sancionada. En el caso aquí presentado, el reconocimiento de los pediatras era instrumental con el fin de subsumir el saber y el hacer “lego” a sus normativas y recomendaciones.

A través del mismo, se ha ejemplificado acerca de la heterogeneidad de los recursos y agentes que intervienen en la resolución de los problemas de salud y su importancia. Ello testimonia que las intervenciones de la biomedicina se ejercen con resistencias y contradicciones.

El contacto directo que mantiene la población con distintos especialistas (médicos, curanderos, pastores), o indirecto a través de los medios de comunicación (particularmente internet y las redes sociales), junto a afiches, folletos, manuales, recetarios, indicaciones farmacéuticas, etc., alimenta formas de asistencia híbridas que resultan de una síntesis de saberes, por cierto ecléctica, alimentada por saberes biomédicos, de medicinas alternativas, de creencias religiosas, de recomendaciones de pares.

Las fronteras entre esos sistemas de atención (“legos”, biomédicos, alternativos), no siempre están claramente delimitadas. Así por ejemplo, resulta interesante ver cómo el surgimiento de la Etnopediatría¹⁵ con su nueva mirada de los niños -descentrada de las normativas científicas hegemónicas-, contribuyó a la proliferación de las redes autogestionadas alrededor de la crianza con apego, que en nuestro país han intervenido en la ley del parto respetado y cuya inclinación hacia lo “natural” en alguna de sus expresiones, sugiere un deslizamiento hacia el biologismo.

Podría decirse que los vasos comunicantes entre los sistemas de atención son crecientes y más fluidos. En parte, por el (re)surgimiento de medicinas alternativas como respuesta a la insatisfacción con una medicina que se percibe

15 Esta corriente fue impulsada en 1995 por antropólogos, biólogos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos estadounidenses y canadienses, preocupados por la crisis mundial que afectaba la salud infantil. Estudiando la crianza en distintas culturas, mostraron que el contacto corporal del bebé con su madre y demás allegados, produce moduladores químicos necesarios para la formación de las neuronas y del sistema inmunológico, y que la carencia de afecto corporal trastorna el desarrollo infantil. Como se observa renovadamente, los contextos de crisis promueven el interés y la apelación a los saberes tradicionales, populares o profanos, los que constituyen un reservorio de alternativas valiosas para resolver problemáticas diversas.

poco eficaz para resolver los problemas crónicos de salud, al desencanto por ciertos efectos del progreso científico y tecnológico en el campo de la salud, entre otras. El escepticismo hacia la medicina y sus desarrollos tecnológicos, le resta univocidad como modelo de referencia.

En todos los países occidentales, especialmente en los centros urbanos más cosmopolitas, se observan las formas más diversas de medicinas alternativas: disidentes o heterodoxos de la biomedicina, herboristería de todo tipo, elementos o instrumentos comerciales de prevención, promoción o cura mágica, formas renovadas de sanadores y de organizaciones religiosas, técnicas orientales de prevención o terapia -yoga, acupuntura, shia-tzu, feng-shui; etc. En general, se trata de modelos holísticos refractarios a las terapias agresivas y no naturales. Este fenómeno, desde ya no ajeno a la globalización y a las migraciones, se acompaña de organizaciones de autoayuda, de movimientos ecologistas, sanitarios, etc. que expresan la revalorización de la naturaleza y del ambiente y el rechazo a las bases del desarrollo de la civilización moderna en occidente (la razón, la ciencia, la tecnología, la industria, el progreso) como garantes del bienestar (Haro Encinas, 2000).

Para ir cerrando: un aspecto sobre el que cabe insistir es que los saberes tanto propios como ajenos, no constituyen objetos acabados, coherentes, cerrados, sino recursos en juego, cambiantes y coyunturales. Tal insistencia se debe a la permanencia de nociones cosificadas de la cultura, en las que imperan imágenes estáticas y simplistas de la diversidad cultural. Con relación a esto, cabe cuestionar la visión según la cual la medicina "tradicional" o "popular" sería patrimonio de los grupos subalternos y que sus creencias, erróneas, atrasadas o primitivas, deberían retroceder ante la clarificación creciente de la ciencia. El problema de las medicinas alternativas no atañe únicamente a los pueblos originarios o a los sectores populares sino que se renueva y revitaliza en todos los sectores sociales, incluso de los países desarrollados. Pensar que las hierbas, o las prácticas de la medicina popular son exclusivas de los estratos bajos, es incorrecto en términos de la evidencia disponible.

El actual pluralismo médico representa un estímulo para que, de la mano de la Epidemiología cultural (Almeida Filho, 1992; Hersch Martínez,

2013; Menéndez, 1998; Menéndez, 2008) la Antropología, la Medicina y la Epidemiología junto con otros actores significativos, emprendan el camino para visualizar de manera ampliada y ajustada, las señales de salud, enfermedad, padecimientos, sufrimientos, dolencias, aflicciones que nos afectan y las terapias correspondientes, las que ameritan un conocimiento riguroso y sostenido de sus resultados.

Bibliografía

- Almeida-Filho N. *Por una etnoepidemiología (Esbozo de un nuevo paradigma epidemiológico)*. Cuadernos Médico Sociales 1992; 61.
- Berlinguer G. *La enfermedad. Sufrimiento, diferencia, peligro, señal, estímulo*. Buenos Aires: Lugar Editorial; 1994.
- Buenos Aires. Ministerio de Salud. Programa Materno-Infanti. *Informe de la Encuesta a Médicos sobre Alimentación durante el primer año de vida*. La Plata: Ministerio; 1998.
- Conrad P, Schneider J. *Sobre la medicalización de la anormalidad y el control social*. En: Ingleby D, comp. *Psiquiatría crítica. La política de la salud mental*. Barcelona: Grijalbo; 1982.
- Foucault M. *La vida de los hombres infames*. Adrid: Piqueta; 1990.
- Fumagalli L, Ortale S et al. *Fiebre en la infancia. Los residentes de pediatría y sus conceptos sobre la misma*. Ludovica Pediatría 1999; 1(2).
- Geertz C. *El impacto del concepto de cultura en el concepto del hombre. La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa; 1989.
- Giddens A. *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu editores; 1989.
- Haro Encinas JA. *Cuidados profanos: una dimensión ambigua en la atención de la salud*. En: Perdiguero E, Comelles JM, eds. *Medicina y Cultura. Estudios entre la antropología y la medicina*. Barcelona: Ediciones Bellaterra; 2000.
- Hersch-Martínez P. *Epidemiología sociocultural: una perspectiva necesaria*. Salud Pública de México 2013; 55(5).
- Herzlich J, Pierret C. *De ayer a hoy: construcción social del enfermo*. Cuadernos Médico Sociales 1989; 43.
- Le Breton D. *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión; 1995.
- Lévi-Strauss C. *Antropología estructural I*. Buenos Aires. Eudeba; 1968.
- Menéndez E. *Factores culturales: de las definiciones a los usos específicos*. En: Perdiguero E, Comelles M, eds. *Medicina y Cultura. Estudios entre la Antropología y la Medicina*. Barcelona: Ediciones Bellaterra; 2000.
- Menéndez E. *Aproximación crítica al desarrollo de la Antropología Médica en América Latina*. Nueva Antropología 1985; 29.
- Menéndez E. *El modelo médico y la salud de los trabajadores*. En: Basaglia F et al. *La salud de los trabajadores*. México DF: Editorial Nueva Imagen; 1978.
- Menéndez E. *Epidemiología sociocultural: propuestas y posibilidades*. Región y Sociedad 2008; 20(2).
- Menéndez E. *Estilos de vida, riesgos y construcción social. Conceptos similares y significados diferentes*. Estudios Sociológicos 1988; 46.
- Menéndez E. *Grupo doméstico y proceso salud/enfermedad/atención. Del teoricismo al movimiento continuo*. Cuadernos Médico Sociales 1992; 57.
- Ortale S, Fumagalli L. *Saber médico y fiebre en la infancia. Estudio comparativo en médicos pediatras y residentes de Pediatría del HIAEP de La Plata*. VI Congreso Argentino de Antropología Social, Mar del Plata; 2000.
- Ortale S. *Prácticas y representaciones sobre desnutrición infantil de causa primaria en familias pobres urbanas del Gran La Plata*. Tesis doctoral [en línea]. La Plata: Facultad de Ciencias Naturales y

Museo; 2003. [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4585>

Ortale S. *Saber médico y desnutrición infantil en el Gran La Plata.*

En: Barone M, Schiavoni L, comps. *Efectos de las políticas de ajuste en la década del '90.* Misiones: Universidad nacional; Secretaría de Cultura; 2005.

Rosaldo R. *Cruce de fronteras.* En: *Cultura y Verdad.* México: Grijalbo; 1991.

Sevalho G. *Uma abordagem histórica das representacoes sociais de saúde e doença* "Cadernos de Saúde Púb. 1993; 9(3).

Tumer V. *La selva de los símbolos.* Madrid: Siglo XXI ed; 1980.

Valentine C. *La cultura de pobreza.* Buenos Aires: Amorrortu; 1970.

Wellin E. *Theoretical reorientations in medical anthropology.* En: *Culture, disease and healing.* New York: Landy ed; 1989.

***Dra. Susana Ortale**

Antropóloga. Posdoc en Ciencias Sociales (CEA/CONICET, Universidad Nacional de Córdoba). Especialista en Evaluación de Políticas Sociales (UNSAM). Investigadora Independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Directora del CEREN, centro CIC/PBA, que realiza actividades de investigación y transferencia en el campo de la alimentación, la crianza, el desarrollo infantil y de las políticas sociales dirigidas a población materno-infantil y adolescente. Investigadora en distintos proyectos sobre pobreza, estrategias de reproducción, desigualdades de género y edad y políticas sociales radicados en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales (dependiente del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales-CONICET/UNLP). Profesora de "Antropología Cultural y Social" (FaHCE-UNLP) y de diversos seminarios de posgrado.

SALUD DEL NIÑO, LA NIÑA Y EL ADOLESCENTE DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS



PROF. DR. JUAN REICHENBACH

Problemas guiones iniciales

Es necesario imaginar la salud del niño, la niña, l@s adolescentes y las madres desde la integralidad, el derecho y con una perspectiva de género, orientando las políticas públicas a esos propósitos. Incluir en este concepto ampliado de salud la influencia negativa que los cambios demográficos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, educativos, alimentarios y la violencia le imprimen. De ello deviene la necesidad de jerarquizar las prioridades sociales de la mujer, la madre, l@s niños. Habrá que actuar sobre la multiplicidad de factores que condicionan morbilidad y sobre la mortalidad reducible. Será necesario recordar que la Argentina cursa una etapa de transición demográfica, con disminución de la natalidad, y que la niñez infancia adolescencia es UN TERCIO DE LA POBLACIÓN y es el futuro. Habrá que reconocer que es insatisfactoria la disminución de la tasa de mortalidad infantil y que además persiste una gran inequidad interjurisdiccional, entre localidades de una misma provincia y entre barrios de una misma localidad. Es evidente que hay aún muchos recién nacidos con bajo peso al nacer, muchos prematuros y maternidad adolescente con riesgos. Las muertes perinatales y en el primer año de vida son REDUCIBLES con MEDIDAS SIMPLES, basadas en la APS, la territorialización, la promoción, la integralidad, la inclusión y el rescate de derechos.

Es claro y preocupante que la violencia atraviesa todas las edades desde el año de vida, que la mitad de las muertes antes del año de vida son reducibles por acciones en el periodo perinatal, que el aborto es de las principales causas de muerte en madres embarazadas. Que las enfermedades infecciosas, emergentes, reemergentes y olvidadas siguen siendo una causa importante de morbilidad en la Argentina (lúes, TBC, coqueluche, dengue, sarampión, Hantavirus, Chagas, VIH, Covid 19). Que se han abandonado en los últimos años las políticas públicas de educación sexual, prevención de ETS, embarazos adolescentes, abortos inseguros, falta de detección precoz del embarazo, de control del mismo, de atención adecuada en sala de partos, de seguimiento de maternidades con Condiciones obstétricas neonatales esenciales (CONE), de seguimiento del puerperio y del RN de riesgo. Que hay un alarmante incumplimiento del calendario nacional de vacunaciones y meseta en el objetivo supremo de la universalización de la lactancia materna. Que continúa incidiendo el síndrome urémico hemolítico. Que hay que mejorar la detección y derivación de los perinatos con cardiopatías congénitas. Que continuamos en emergencia alimentaria, que hay que erradicar el hambre y las enfermedades de la malnutrición, incluida la anemia y la carencia de oligoelementos. Que se debe mejorar el abandono interanual en el ciclo Primario y secundario y eliminar el trabajo infantil y adolescente. Que se

debe incluir en la agenda pública la salud mental, la “epidemia” de suicidios adolescentes y los accidentes en la vía pública. Que habrá que sanear el agua, el aire, los suelos, el medio ambiente reparando en esta invasión creciente de agroquímicos y tóxicos industriales. Que habrá que pensar desde las políticas públicas en una salud para el niño, la niña y los adolescentes centrada en derechos y con perspectiva de género.

La salud como derecho DEL NIÑO, LA NIÑA Y L@S ADOLESCENTES

Algunas cifras (referimos las últimas cifras oficiales. Año 2107)

- Primer año de vida fallecieron 6.579 niños y niñas (17.9 muertes por día)
- El 59 % de esas muertes, 3.818, son reducibles en el primer año de vida (10.6 muertes por día)
- En ese mismo año fallecieron 3.294 adolescentes entre 10 a 19 años (12 muertes por día)

Mortalidad

- Accidentes de tránsito (16.5%) más de 500 muertes/año (1,5 por día)
- Suicidios (11%) más de 400 muertes/año (1,1 por día)
- Agresiones más de 200 muertes/año, otras causas externas de traumas accidentales más de 100 muertes/año, accidentes no especificados 100 muertes / año.
- Ahogamiento y sumersión accidental 62. (1.3 por día)

Morbilidad

- Tuberculosis en menores de 19 años (6.9 casos nuevos por día)
- Sífilis congénita (3.3 casos nuevos por día)
- Síndrome Urémico Hemolítico (1 caso nuevo por día)

Una de las Metas de los ODS de Naciones Unidas es “poner fin a todas las muertes evitables de RN, Niñas y Niños menores de 5 años”.

Comentario: Este análisis “matemático”, por día, nos posiciona frente a la magnitud de la empresa: 10,6 muertes reducibles en el primer año de vida, 3,3 casos nuevos de lúes evitables diariamente, casi 7 casos diarios de TBC antes de los

19 años. Habrá que mejorar la incidencia de los determinantes sociales de la salud, desarrollar la búsqueda activa de la enfermedad, prevenir lo prevenible. *“Esto no se arregla con suero y terapia intensiva. Hay que ir casa por casa, donde vive y donde trabaja la gente”.* Alberto Alvarado.

Tasa de mortalidad infantil

- 9.3/1000 nacidos vivos en el país
- 9.4 Bs As. /16 Formosa /6.9 CABA

Hay brechas e inequidad clara.

	País	Buenos Aires
NEONATAL (Muertes en el primer mes de vida)	6.4	6.3
Neonatal precoz (Muertes en los primeros 7 días de vida)	-	4.4
Tardía (Muertes entre los 7 y 29 días de vida)	-	1.9
POST NEONATAL (Muertes entre el mes y el año de vida)	2.9	3.1

Comentario: Continuamos con tasas de mortalidad infantil altas de acuerdo a nuestras posibilidades como pueblo. La inequidad se esconde, subrepticamente, y condiciona diferencias inmorales entre los niños que viven en distintas zonas de una misma región, en distintas ciudades de una misma provincia y en distintos barrios de una misma ciudad.

Muertes en el primer año de vida

Causas	% País 2017
Afecciones originadas en el periodo neonatal	52
Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	28
Enfermedades del Sistema Respiratorio	6
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3
Causas externas	2
Otras	9

Comentario: Sin duda los eventos perinatales, los relacionados con el mal control del embarazo, con la atención del recién nacido en la sala de partos y con los sucesos de la primera semana

de vida determinan estas cifras que hacen creíble este axioma "Dime donde naces y te diré si vives". Se requieren desarrollo de las maternidades con CONE, de las redes de atención perinatal y fundamentalmente, un adecuado control de la gestación.

- ✓ Los niños, niñas y adolescentes son la 3ª parte de la Población (32,2% de la población total del país)
- ✓ CABA es la más envejecida. Misiones la más joven (39,2 % de la población)
- ✓ En la Provincia de Buenos Aires la distribución por grupos de edades era la siguiente:
 - 0 a 4 años __ 8,5%
 - 4 a 9 _____ 8,4%
 - 10 a 14 _____ 7,8%
 - 15 a 20 _____ 7,5% de la población total.

En lo que se refiere a la natalidad en el 2017 NACIERON EN EL PAÍS 704.609 RN (16 nacimientos cada 1.000 habitantes.). En Misiones 21 nacimientos cada 1000 habitantes en CABA 11, en Bs.AS, 15.

Los RN con BAJO PESO AL NACER (Menos de 2.500 gm.) fueron 7,3 de cada 100 RN vivos. 2/3 DE ELLOS ERAN PREMATUROS. Los RN con MUY BAJO PESO AL NACER (menos de 1500 gm) fueron 1,1 de cada 100 RN vivos. (7.781 RN en 2017). 13 de cada 100 niños nacieron de madres adolescentes (menores de 20 años).

Según el criterio clásico de reducibilidad, 55% de las muertes neonatales (2502) y el 68% (1379) de las post neonatales se podrían haber evitado, lo que suma 3.881 muertes reducibles en el primer año de vida, sobre un total de 6.579, o sea el 59% del total en ese lapso.

Número de nacimientos	704.609
Madres entre 15 y 19 años	91.586
Madres menores de 15 años	2.493

Muertes en el periodo neonatal 2017. n 4.550

Trastornos Respiratorios y Cardiovasculares	26%.
Prematurez y Bajo Peso al nacer	21 %
Otras afecciones periodo prenatal	21%
Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	19%
Malformaciones congénitas sistema circulatorio	9%

Muertes en el periodo post neonatal 2017. n 2029 muertes

Malformaciones congénitas sistema circulatorio	14%
Enfermedades sistema respiratorio	13%
Malformaciones cong, deformidades, anomalías cromosómicas	12%
SMSL	7%
Otros	6%

Afecciones originadas período neonatal	6%
Neumonía	6%
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	5%
Septicemia	5%
Trastornos relacionados con prematurez y bajo peso	3%

Mortalidad según peso al nacer

Solo el 50% de las muertes en el primer año de vida están condicionadas por los RN de más de 2500 gm al nacer que son el 93% de todos los RN. Los que pesan menos de 2500 gm (el 7 % del total) abonan el 50% de muertes restantes, sobre todo los que pesan menos de 1500 gm (1%).

De ello se deduce que deben evitarse los nacimientos de RN con peso inferior a 2500 gm. Y ello se logra antes del periodo concepcional y durante, con medidas adecuadas de control y

seguimiento de las madres embarazadas.
Promoción versus reparación.

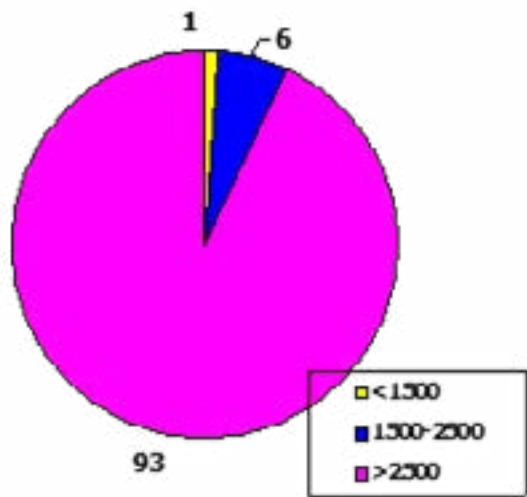
Muertes neonatales precoces y tardías, post neonatales y reducibles

Según el criterio clásico de reducibilidad:

- 55% de las muertes neonatales (2502)
- 68% de las postneonatales (1379) se podrían evitar.

3.881 muertes reducibles en el primer año de vida sobre un total de 6.579. O sea el 59% del total en ese lapso.

Recién nacidos según peso al nacer



Mortalidad según peso al nacer



	Edad	Nº de Muertes Totales	Muertes Reducibles	
NEONATAL PRECOZ	(0 a 6 días)			Mortalidad neonatal precoz
NEONATAL TARDÍA	(7 a 27 días).			Mortalidad Neonatal tardía
RECIÉN NACIDO	(0 a 27 días)	4.550	2.502 (55%)	Mortalidad Neonatal
POST NEONATAL	(28 días al año)	2029	1379 (68%)	Mortalidad Post Neonatal
TOTAL		6579	3.881(59%)	Mortalidad Infantil

Mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años. 2017. n1194.

- Causas externas de mortalidad 30%
- Malf. Congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 13%
- Enfermedades del sistema respiratorio 13%
- Tumores (neoplasias) 12%

Enfermedades

Mortalidad en Niños y niñas de 5 a 9 años. n 725.

- Causas externas 30%
- Accidentes de tránsito y vehiculares 29%
- Traumatismos accidentales 29%
- Ahogamiento 8%
- Enfermedades del sistema respiratorio 9%
- Malformaciones Congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 7%
- Tumores malignos 17%

n128 Leucemia aguda en el 46%.

Mortalidad de adolescentes. 10 a 19 años. n 3294.

2 de cada 3 eran varones y el 75% de las muertes ocurrieron entre los 15 y 19 años.

- Causas externas 1893 (57.5%)
- Tumores 316 (9.7%)
- Enfermedades sistema circulatorio 171 (5.2%)
- Enfermedades sistema respiratorio 196 (5.9%)
- Enfermedades infecciosas y parasitarias 93
- Malf cong, deformidades, anomalías cromosómicas 75
- Trastornos metabólicos 34

Causas Externas de Mortalidad de los Adolescentes.

- Accidentes de tránsito (16.5%) más de 500 muertes
- Suicidios (11%) más de 400 muertes
- Eventos de intención no determinada Mas de 300 muertes
- Agresiones Más de 200 muertes
- Otras causas externas de Traumas accidentales Más de 100
- Accidentes no especificados 100
- Ahogamiento y sumersión accidental 62
- Complicaciones en atención médica y qui-

rúrgica 10

- Los suicidios son 1 de cada 3 de las muertes asociadas a causas externas en los adolescentes de 15 a 19 años. MUCHAS DE LAS MUERTES EN LA ADOLESCENCIA
- del Sistema Nervioso 8%

TAMBIÉN SON REDUCIBLES Y EVITABLES

Mortalidad absoluta

En el primer año de vida	6,579
de 1 a 4 años	1,194
de 5 a 9 años	725
10 a 19 años	3294
TOTAL ANUAL de muertes entre 0 y 19 años	11,792

Comentario: las cifras hablan por sí solas. Muertes evitables o reducibles con políticas destinadas al desarrollo humano integral, que prioricen el futuro hecho niños, madres y adolescentes. Que valoren la salud sobre la enfermedad. El derecho de los sujetos a una vida digna. La equidad.

Morbilidad

En estos grupos poblacionales las morbilidades preeminentes se dividen en dos grandes grupos de enfermedades.

- ✓ ENFERMEDADES INFECCIOSAS
 - ETS transmitidas verticalmente
 - Reemergentes
 - Prevenibles por vacunas
 - Las de tratamiento médico probado que persisten
- ✓ NO TRANSMISIBLES
 - Cánceres pediátricos
 - Cardiopatías congénitas

En este renglón observamos:

Sífilis congénita. En preocupante ascenso. En el 2017 hubo una tasa de 1,7/ sífilis congénita cada 1000 RN vivos. n 1.197 casos.

Sífilis en embarazadas. En ascenso. En 2017 Tasa de 3.2/1000 nacidos vivos. n 2.252 casos.

Casi la mitad de las madres con sero prevalencia no fueron tratadas en el embarazo, generando RN con lúes, lo que evidencia un insuficiente

o inadecuado seguimiento de las embarazadas.

Síndrome Urémico Hemolítico.

300 a 400 casos nuevos por año. Endémica. En meseta. Los más afectados son niñas y niños menores de 5 años. n 361 en 2017. El control de las carnes en los frigoríficos, en los mataderos, en las carnicerías y los comercios. El control de las aguas y de la leche parecen ser medidas más económicas y éticas que tratar una insuficiencia renal en los excelentes centros de diálisis. La cultura de la enfermedad versus la cultura de la salud.

Coqueluche.

Luego de la vacunación con triple bacteriana acelular (2013 en el calendario Nacional) las tasas de letalidad de coqueluche muestran una curva en descenso. Tasa. 2 casos de coqueluche cada 100.000 habitantes. Las inmunizaciones junto con la lactancia materna y la SRO han sido un trípode eficiente en la salud pública mundial.

Tuberculosis.

n 1917 casos de TBC en menores de 19 años, preferentemente en la población entre 15 y 19 años. Persistente y ancestral afección que señala sin dudas las condiciones socio ambientales.

Influenza A

n 1431 muestra positiva en menores de 2 años y 2656 hasta los 15 años. Desde 2011 la vacuna está en el calendario Nacional entre los 6 y 24 meses y mayores de 2 años con factores de riesgo. En ascenso

Infecciones respiratorias.

En 2017 representaron el 6% de las causas de muerte en menores de 2 años. Las infecciones respiratorias bajas son el motivo de consulta e internación más frecuente en los hospitales del país. Las muertes son condicionadas por una multiplicidad de factores, pero es de destacar la observación de diagnósticos tardíos, falta de acceso, derivaciones inadecuadas, iatrogenias medicamentosas además de las condiciones de los huéspedes niños con determinantes sociales de enfermedad estructurales.

Dengue.

La mayor epidemia de la que se tiene registro en el 2020. Ver artículo respectivo en este libro. La punta del iceberg del abandono de nuestro medio ambiente, del fracaso del autocuidado, de la atención primaria de la salud, de la ausencia de políticas previas de promoción de la salud comunitaria.

Rotavirus.

Se incorpora la vacuna en el 2015. Las tasas disminuyeron abruptamente 140/ 100.000 en menores de 1 años a 30/100.000. (5 veces menos). 40/100.000 de 1 a 4 años a 10/100.000. (4 veces menos)

CÁNCER.

En el trienio 2014-2016 se registraron 4107 (X 1350 por año) casos de cáncer en menores de 15 años, 37,6% eran leucemias.

Causas. Incidencia aprox. por año

• Leucemias	500
• Tumores SNC	250
• Linfoma y SRE	150
• Partes blandas	80
• Neuroblastoma	80
• Oseos	70
• Renales	60
• Retinoblastoma	40
• Cel. germinales	40
• Epiteliales	30
• Hepáticos	10
• Varios	5

Cardiopatías congénitas.

Entre 2011 y 2014 se incrementaron las denuncias de CC en un 36% y las cirugías en un 31%.

Entre 2012 y 2017 se realizaron 24.567 denuncias de CC (58% en menores de un año) y se operaron 9887.

Mortalidad Pre y posquirúrgica del 4.8%.

El diagnóstico antenatal, la derivación oportuna, el acceso y la experiencia de los equipos es trascendente en la reparación y sobrevida.

La malnutrición es una epidemia oculta. Disfrazada de excesos o defectos, con pronóstico de dificultades transgeneracionales. Es una pandemia mundial de inequidad, de exclusión, de privación de derechos.

Plenamente de acuerdo con Los Objetivos de la Estrategia mundial para la salud de la Mujer, el niño, la niña y el adolescente (2016-2030) de la ONU (ver anexos), es claro que deberemos dejar la semántica de las grandes organizaciones y poner manos a la obra. Desde políticas de humanización en este mundo dirigido por inhumanos.

SITUACIÓN NUTRICIONAL en %

Menores de 2 años	2 / 4 años	5 / 9 años	10/ 19 años
Eutróficos	61	58	57
Emaciación	2	3	2
Bajo Peso	3	3	2
Baja Talla	9	7	2
Sobrepeso	18	18	22
Obesidad	7	11	15

QUIERO IMAGINAR

*Quiero imaginar un siglo nuevo
recrearlo con silencios ausentes
sin futuros sufrientes.*

*Dibujar la fantasía
de ojos sin tristeza
mañanas sin frío
gestos sin dolor.*

*Vencer la injusticia
de una herida de hambre,
de una esperanza inundada,
de una y tantas noches,
con tos y con frío,
sin pan y sin sopa
Juan Reichenbach.*

ANEXO

Los Objetivos de la Estrategia mundial para la salud de la Mujer, el niño, la niña y el adolescente

Los Objetivos de la Estrategia mundial para la salud de la Mujer, el niño, la niña y el adolescente pretenden concluir con ODM, corregir inequidades en y entre países y aplicar la Agenda de desarrollo sostenible 2020-2030. La estrategia mundial de desarrollo sostenible está centrada en la equidad. Su eje es la protección de mujeres, niños y adolescentes que viven en entornos difíciles.

Pretende:

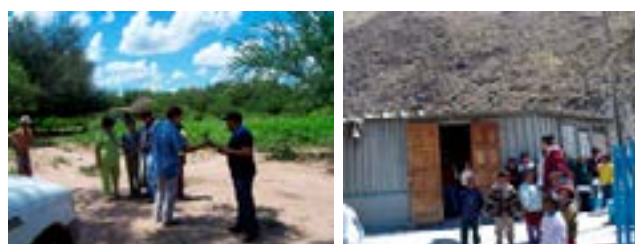
- ✓ SOBREVIVIR. Poner fin a la mortalidad prevenible
- ✓ PROSPERAR Lograr la salud y el bienestar
- ✓ TRANSFORMAR. Ampliar entornos propicios

Una evaluación inicial realizada en 2016 de los

datos más recientes disponibles sobre los 16 indicadores clave para la aplicación de la Estrategia Mundial revela que, en relación con el objetivo «sobrevivir», en 2015

- ✓ la razón de mortalidad materna estimada a escala mundial era de 216 por 100 000 nacidos vivos;
- ✓ la tasa de mortalidad de menores de cinco años era de 43 por 1000 nacidos vivos;
- ✓ la tasa de mortalidad neonatal era de 19 por 1000 nacidos vivos;
- ✓ y la tasa de mortinatalidad era de 18,4 por 1000 nacimientos totales.

Con respecto al objetivo «prosperar», se estima que el crecimiento de 156 millones de niños pequeños (el 23% del total de niños pequeños) en todo el mundo sufrió retrasos en 2015 y que la tasa de natalidad fue de 44,1 por 1000 mujeres entre las adolescentes de 15 a 19 años. En lo que concierne a la cobertura de servicios sanitarios esenciales, en 2016 se satisficieron las necesidades en materia de planificación familiar del 77% de las mujeres con métodos anticonceptivos modernos, el 58% de las embarazadas en las regiones en desarrollo tuvieron al menos cuatro visitas de control prenatal, el 39% de las madres alimentaron exclusivamente con leche materna a sus hijos durante el periodo recomendado de seis meses en países de ingresos bajos y medianos, y el nivel de cobertura con tres dosis de la



vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina alcanzó el 86%. En 2016, el 78% de las mujeres fueron asistidas en el parto por personal sanitario cualificado. Entre 2007 y 2014, el 58% de los niños menores de cinco años con presunta neumonía recibieron atención y el 49% de los niños menores de cinco años con diarrea recibieron terapia de rehidratación oral.

Las cifras son los promedios no ponderados para 192 países, territorios y regiones con datos de origen de la base de datos mundial sobre gasto sanitario de la OMS (<http://apps.who.int/nha/database/Home/Index/es>).

Con respecto al objetivo «transformar», la proporción de niños menores de cinco años cuyo nacimiento ha sido inscrito en un registro civil fue de 74% en todo el mundo en 2014, pero solo 45% en los países menos adelantados. Se estima que el 30% de las mujeres y niñas de 15 años o más que han tenido pareja han sufrido violencia física y/o sexual infligida por su pareja actual o anterior en algún momento de su vida; la proporción es de 29% entre las mujeres de 15 a 19 años. Asimismo, se estima que alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales forzados en algún momento de su vida. Los Estados Miembros han identificado la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas como una prioridad importante para mejorar la salud de la mujer, el niño y el adolescente.

¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?

En la Agenda 2030 se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son metas que garantizarán un futuro mejor para todos. Son los siguientes:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
9. Industria, innovación e infraestructuras
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Bibliografía

Argentina. Ministerio de Salud. Dirección de estadísticas e información de la salud. (2017) Estadísticas vitales. Información básica. Serie 5. N° 61.

AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS: PRÁCTICAS DE CUIDADO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO A LA SALUD DESDE UNA MIRADA SOCIAL



LIC. VALERIA ANDREA BELMONTE*

LIC. LILIANA MINGILLO**

DR. JORGE LUIS PEPE***

Sumario

Trabajo de investigación para doctorado, acerca del agua segura como recurso insustituible de la salud poblacional. Producto de la investigación realizada en Concepción del Uruguay-ER-AR, se han encontrado algunos hallazgos empíricos, que ponen a la luz la complejidad del cuidado infantil y las prácticas preventivas con el agua para el consumo de niños menores de 1 año de edad. A través de una perspectiva socio ambiental con un enfoque cuantitativo y cualitativo, se exploró y trató de comprender las cuestiones relacionadas con las percepciones de riesgo y las prácticas con el agua de consumo en el hogar de grupos domésticos en el desarrollo de la infancia. El estudio acerca de los microambientes domésticos permitió alcanzar espacios territoriales diferenciados por condiciones de vida y salud que no son alcanzados o visibilizados por los datos censales y las políticas de estados.

El agua como determinante de la salud infantil

La disponibilidad y acceso al agua para el consumo humano es uno de los principales retos desde la salud ambiental que deben enfrentarse en la actualidad, ya que una sexta parte de la población no tiene posibilidad de adquirir agua

potable (1100 millones) y casi 40% carece de saneamiento (2.400 millones). (Carabias, Landa, Collado, Martínez, 2005)

La evidencia epidemiológica especialmente de investigaciones sugiere que la calidad del agua de bebida desempeña un papel importante en la transmisión fecal-oral y que se relaciona altamente con el contexto. (Bain, Cronk, Wright, Yang, Slaymaker y Bartram, 2014)

Según los datos consultados, en todo el mundo, un millón trescientas mil muertes por diarrea al año son causadas principalmente por la ingestión de patógenos en agua insegura, alimentos contaminados o simplemente por falta de higiene, y la mayoría se registran en países en vía de desarrollo, concentrándose en comunidades con condiciones de vida no favorables (Prüss-Üstün, Annette & World Health Organization, 2008).

En Argentina, según los últimos datos a los que se tuvo acceso, los avances registrados en la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en la infancia han sido importantes y, en 2009, el número de defunciones por esta causa en el total del país, ha sido un 95,8% más bajo que el que se había registrado en 1980. Sin embargo, este avance no se distribuyó en forma uniforme en todo el país. (MSN, 2011).

Contar con agua segura es esencial para la salud de los consumidores y constituye el objetivo primordial del tratamiento del agua y del control de calidad del agua de consumo, cuyas características finales dependerán de su origen (agua subterránea o superficial) y del tratamiento de potabilización al que sea sometida.

La legislación argentina, responsabiliza al Estado del asegurar y monitorear la calidad del agua potable de la red de abastecimiento. Esta es definida, según el Código Alimentario Argentino en su artículo Art. 982 (2008), como agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario aquella que es apta para la alimentación y uso doméstico que no contiene sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Además, deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente, debiendo cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas establecidas en la Ley N° 18284 del código.

Según los resultados del Censo 2010 el 83.9% de los argentinos usaban la red pública como fuente principal de agua para beber y cocinar, 14.8% agua de perforaciones o pozos, mientras que un 1.3% tenían como fuente principal de agua para beber y cocinar la colecta de agua de lluvia, carro-cisternas, ríos, canales o arroyos. (INDEC, 2012). Sin embargo, el acceso a sistemas de agua mejorados no garantiza agua segura. (Bain, Cronk, Wright, Yang, Slaymaker y Bartram, 2014) Las distintas poblaciones consumen agua de diversas formas de abasteciendo y estas desempeñan a menudo tareas importantes en la captación, tratamiento y almacenamiento de agua.

Respecto a los tipos de abastecimiento y haciendo clara referencia a las deficiencias que resultan del gran crecimiento urbano, se observan importantes fallas en las redes de agua potable, o las construcciones de pozos para el abastecimiento de agua subterráneas, así como también poblaciones vulnerables, que ante la necesidad realizan conexiones clandestinas para la obtención del agua para consumo.

Diversos estudios revelan, respecto a las prácticas preventivas con el agua en los hogares, que los tratamientos más comunes son hervir y filtrar, aunque hoy en día es importante el avance de la compra de agua embotellada

con las implicancias que ello conlleva respecto a los controles por parte del Estado. (Hobson, Knochel, Byington, Young, Hoff, & Buch, 2007). (Zabaleta Moreno, 2003) (Morua, Halvorsen, y Mayer, 2011) (Corral Verdugo, Frías Armenta y González Lomelí, 2003); (Mozobanczyk y Pérez Sobrero 2016).

Prácticas con el agua de consumo para los niños que realizan los cuidadores

Las prácticas que realizan los cuidadores de los niños con el agua de consumo, se asientan dentro de las denominadas prácticas de crianza. Estas refieren a comportamientos cotidianos con que los adultos buscan guiar, modelar, vigilar, cuidar, el crecimiento y el desarrollo infantil. (Myers, 1993), (Colángelo, 2012). Respecto a este tipo de cuidado, se entiende que surge desde el cruce de las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado, y los modos en que las familias de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros acceden, o no, a ellos.

Desde las nuevas concepciones del cuidado infantil, el Estado cumple un papel central, ya que actúa simultáneamente como un agente proveedor de servicios y como un ente regulador de las contribuciones de otros “pilares del bienestar”. (Santillán, 2010; Ortale y Santos, 2014; Ortale, 2015)

Por otro lado, los comportamientos en salud se relacionan con la percepción de riesgo a la misma, como así lo sostienen diferentes teorías en el campo comportamental. (García del Castillo, 2012), (Brewer, Chapman, Gibbons, Gerrard, McCaul, y Weinstein, 2007). El cambio en el comportamiento de salud involucra una diversidad de factores sociales, cognitivos y emocionales que operan en concierto. Estos temas han sido objeto de estudio por parte de investigadores y teorías que actualmente se encuentran en debate en Psicología de la Salud, y que se han propuesto para intentar explicar la ocurrencia de la conducta protectora de la salud y preventiva de la enfermedad.

La teoría de la acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980) se ha utilizado para estudiar conductas complejas como en el caso del uso del agua, la misma toma en cuenta la intención como un determinante inmediato de la acción y a esta le antecede el conociendo y las percepciones. La intención depende de dos factores,

uno de naturaleza personal, que es la actitud, referido a la evaluación positiva o negativa que hace el individuo acerca de si es bueno o malo ejecutar cierto comportamiento, y el otro que refleja la influencia social y se conoce como norma subjetiva, esto es, la persona responde de manera selectiva a ciertos grupos que son significativos porque representan un punto ideal con el que se compara y a través del cual evalúa lo apropiado de su conducta. (Ajzen y Fishbein, 1980) (Arreguín-Moreno, Román-Pérez, Laborín-Álvarez, Moreno, Valdez, & Valenzuela, 2009), (Stefani, 2005)

Algunos hallazgos de una investigación en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos

Producto de la investigación realizada en Concepción del Uruguay-ER-AR, se han encontrado algunos hallazgos empíricos, que ponen a la luz la complejidad del cuidado infantil y las prácticas preventivas con el agua para el consumo de niños menores de 1 año de edad.

A través de una perspectiva socio ambiental con un enfoque cuantitativo y cualitativo, se exploró y trató de comprender las cuestiones relacionadas con las percepciones de riesgo y las prácticas con el agua de consumo en el hogar de grupos domésticos en el desarrollo de la infancia. El estudio acerca de los microambientes domésticos permitió alcanzar espacios territoriales diferenciados por condiciones de vida y salud que no son alcanzados o visibilizados por los datos censales y las políticas de estados

Las participantes del estudio fueron (n= 50) madres/cuidadores de niños de 6 a 12 meses de edad, que concurren a la consulta pediátrica de Centros de Atención Primaria de Salud (CPAS) de la Ciudad de Concepción del Uruguay.

De acuerdo con las posibilidades de atención de cada centro de salud, se realizaron entrevistas a las madres y grupos focales, lográndose una muestra de 50 madres en entrevistadas y 16 de ellas que formaron parte de los grupos focales.

La triangulación de métodos y técnicas de recolección de datos, como las encuestas y los grupos focales, permitieron analizar las experiencias y las percepciones a que dan lugar las madres desde un enfoque fenomenológico. Por lo tanto, se tomó como fundamento epistémico

el construccionismo social y como metodológico la fenomenología, ya que lo valioso e importante de esta investigación fue explorar las realidades de las madres y las construcciones que forman parte de su mundo subjetivo. (Sajama, 1992).

Cabe destacar que las madres de los niños fueron las protagonistas de la investigación ya que ellas acudieron a los Centros de Salud en búsqueda de cuidado para la salud de sus hijos, no encontrándose padres o tutores. El 44 % de las mismas refirieron menos de 12 años de educación formal.

Según los relatos de las entrevistadas, casi la mitad de los hogares se categorizaron dentro de una población con posibilidades de satisfacer las necesidades básicas además del desarrollo intelectual y de tener capacidades para disfrutar de beneficios culturales. Solo una de cada diez sería la población en pobreza crítica. (Estrato bajo inferior según indicadores de la Escala de Graffar-Méndez Castellano). (Graffar-Méndez Castellano,) Respecto al tipo de configuración familiar, el 76 % se encuadran dentro de las llamadas familias nucleares completas.

De los relatos de las madres, se detectó que el (96%) tienen acceso al suministro de agua potable (canilla domiciliaria, canilla comunitaria, camión cisterna) en su mayoría del sistema de distribución de agua a través de conexiones domiciliarias (90 %) y solo el 4 % utilizaban agua de pozo de uso particular.

Prácticas con el agua para el consumo de los niños

En cuanto a las decisiones y conductas que asumen las madres entrevistadas sobre el agua para beber de los niños, aparecen un (74%) de madres que utiliza el agua domestica cualquiera sea su fuente de abastecimientos, provista por el estado (canilla doméstica, canilla comunitaria o acarreo del camión cisterna municipal) o de perforaciones (agua de pozo) y un (26%) que decide comprar agua embotellada.

De las madres que no compraban agua (n = 37), se determinó que, aproximadamente un (60 %) de éstas, tenían como conducta cotidiana hervir el agua para los niños y un (40%) no realizaban ningún tipo de práctica o tratamiento con el agua. Este grupo de madres que no han adoptado un comportamiento preventivo, pertene-

ce en su gran mayoría al grupo consume agua que proviene de red domiciliaria (salvo una de ellas que acarrea agua desde el camión municipal). Esta situación podría deberse, según algunos autores, a la capacidad de evaluación de la información científica, sobre todo de personas con mayor nivel educativo, que presenta argumentos a favor de la excelencia de la calidad de agua de un servicio público, (Dupont y Krupnick, 2010). También, podría deberse a la falta de conocimiento sobre los tipos de enfermedades transmitidas por el agua y sobre los mecanismos de transmisión, de estas enfermedades. (Guedes, Simão, Dias, y Braga, 2015). En este sentido, cabe destacar que 9 de las 15 madres que conforman este grupo, tienen menos de 12 años de educación formal.

Respecto a la práctica de utilizar agua embotellada, que parecería ser una decisión del 26% de las madres del grupo, según el análisis de los datos, se encontró asociación significativa, con $p < 0,02$, entre el uso de agua embotellada y los años de educación formal. En cuanto a la situación socio económica de las madres, no se encontró asociación significativa. Aun así, no es una práctica que llevan a cabo las madres en situación de pobreza crítica.

Según distintos autores, el consumo de agua embotellada ha aumentado constantemente en la última década, incluso en países donde la calidad del agua de red domiciliaria se considera excelente. Tal es el caso de Argentina que es, además, el país en el que más se consume agua embotellada de América Latina (que incluye agua mineral, de mesa y saborizada. Según un análisis de la consultora Euromonitor International, se toman en estas tierras 114,23 litros per cápita al año. (Guedes, Simão, Dias, y Braga, 2015).

Sin embargo, se asegura que esta situación parecería no entenderse ya que los estados han puesto énfasis y asumidos compromisos en el suministro de agua potable, además de ser el agua embotellada un producto de alto costo, respecto al agua de red. (Doria, 2006) Asimismo, en la actualidad existe un gran debate en los medios de comunicación y en la literatura científica sobre los méritos y fallas de este consumo. Según distintos autores, desde una perspectiva estrictamente objetiva, sostienen que el agua embotellada no es necesariamente “me-

jor” o “peor” que el agua de red y, depende de la especificidad de los casos particulares.

Existen varios estudios que compararon el agua embotellada y de la red asumiendo que mientras que algunas aguas embotelladas tienen mejor calidad que la de red, esta situación no es algo que se repita siempre. Otros señalaron que el agua de red está controlada por estándares más rigurosos y es frecuentemente más analizada que el agua embotellada. En contraposición, aparecen argumentos científicos que dicen, que el agua embotellada se somete a tratamientos más avanzados y se encuentra menos expuesta a la contaminación durante la distribución, siendo un producto más seguro. (Saleh y col. 2001). (Hu, Morton, y Mahler, 2011). (Doria, 2006)

Además, la fluoración del agua es ampliamente reconocida para reducir las caries infantiles. Los niños que beben poco o nada de agua de la canilla pueden no estar recibiendo los beneficios de la fluoración del agua, ya que algunos tipos de agua embotellada y filtrada carecen de fluoruro. (Fernández, Giacaman y Cury, 2014). (Durán, Durán, Ojeda y Castellanos, 2017)

En la Argentina, según la Sociedad Argentina de Pediatría, coincidentemente con estudios realizados por la OMS, existe una elevada prevalencia de caries en la población de niños y adolescentes. (OMS, 2003) (SAP, 2006) por lo cual, en países en desarrollo se presenta como un problema de salud pública.

Respecto al suministro de agua de pozo, solo dos madres de este grupo, con educación universitaria y situación socioeconómica buena, explicaron que el agua de consumo de sus hogares procede de perforaciones accionadas por bombas (pozos tubulares) dado que en su zona de residencia no dispone del servicio de agua de red, por lo tanto, compraban agua embotellada. Sin embargo, si dichas perforaciones se ajustan a las normas sanitarias correspondientes, esto es entre otras, que estén correctamente contruidos y un monitoreo en tiempo y forma de la potabilidad del agua, permiten obtener agua apta para beber sin necesidad de someterla a ningún tratamiento corrector. Así mismo, ante el riesgo de contaminación que significa la acción de la sociedad en el desarrollo de las actividades productivas (industrias, ganadería, agricultura, etc.) es importante contar con algún sistema de tratamiento cuyo grado estará determinado

por la naturaleza y el grado posible de contaminación y por las características del agua bruta. (Prieto y Del Pozo, 2006).

Percepción de riesgo a la salud del agua de consumo de las madres

La diversidad de prácticas cotidianas reveladas por las madres parecería estar atravesados por los valores atribuidos al agua y las percepciones de riesgo en la utilización de ésta. Es reconocido en la literatura científica, que existen relaciones consistentes entre las percepciones de riesgo y la conducta, lo cual avala la idea de que dichas percepciones funcionan como conceptos medulares en las teorías de la conducta hacia la salud. (Brewer y col 2007) (Arellano y col 2009) (WRI, 2000)

En este sentido, y en cuanto a la percepción de la calidad del agua, de los testimonios de las madres entrevistadas y a través de sus interpretaciones, se vislumbra que la mayoría percibe que la misma no es de buena calidad y representa un riesgo sobre todo para la salud de los niños. (82%).

En estos procesos perceptivos, se evidencia que las madres han incorporado, en mayor o menor grado, los aspectos cognitivos, interpretativos y valorativos. Sobre todo, que, si bien son percepciones individuales, están mediadas por la experiencia social. Esta afirmación estaría fundamentada en que estos aspectos se repiten una y otra vez entre las distintas entrevistas, por lo que se supone una elaboración comunitaria de tales percepciones, que se generan a partir de los procesos comunicacionales de la vida cotidiana.

Siguiendo a Benez y col (2010), fue posible establecer percepciones basadas sólo por los sentidos, y otras a través de la cognición, las primeras hacen referencia a procesos derivados de la experiencia directa con el entorno, mientras que la cognición se refiere a aquellos procesos que implican información ambiental “no presente” en el momento concreto, la cual está almacenada en la memoria.

Según los relatos, se asumiría que las percepciones maternas, se han derivado, sobre todo, de la experiencia directa con el agua y las características organolépticas de la misma que han afectado los sentidos como el olor, color y sabor (especialmente). En este sentido, el “olor

a pescado o a cloro que resaltaron las madres, es un ejemplo de las experiencias previas con el fuerte olor a cloro presente en sustancias para la limpieza doméstica o la cercanía al río.

Estos hallazgos son coincidentes con investigaciones nacionales e internacionales sobre la percepción de la calidad del agua para el consumo de diferentes grupos sociales donde la experiencia sensorial directa aparece como una fuente privilegiada en la percepción de la calidad. (Jones y col. 2007), (Chen y col. 2012), (Doria y col. 2009) (Doria, 2006) (Ramos da Silva y col, 2010), (Urrutia Flores, 2016), (Mozobanczyk y Perez Sobrero, 2016), (Prieto y Del Pozo, 2006).

Además, se asume que las madres, en el proceso perceptivo, representan la realidad cotidiana y esta es apropiada según su grupo de pertenencia, a los hechos históricos de ciertos eventos relacionados con la calidad del agua, así como por la preocupación por problemas de salud de sus familias en especial de sus hijos. Por lo tanto, el rol atribuido y desarrollado como madres, demarca dicha preocupación.

Algunos autores, han denominado a esta situación como efecto madres (Dupont, Adamowicz, Krupnick, 2010) (Dupont, 2004) Desde las políticas públicas, las características organolépticas del agua deben considerarse elementos cruciales para la planificación de los servicios de abastecimiento de agua y la vigilancia de la calidad del agua potable ya que estas pueden indicar peligros asociados al abastecimiento o a otras formas de exposición de la población. La detección de, por ejemplo, sabor al agua, puede llevar a aquella a asociarla como no segura para el consumo, llevando al rechazo y la opción por otras fuentes de agua, que no necesariamente son objeto de acciones de control y / o vigilancia de la calidad. (Soares, Carmo, y Bevilacqua, 2017).

Prácticas con el agua de consumo, percepción de riesgo y actitudes materna dentro de un marco social

Desde la información reelaborada a partir de las entrevistas individuales y desde la obtenida de los grupos focales, algunos rasgos de los supuestos de esta tesis se ponen en evidencia.

En principio, y sin hacer generalización de los resultados por el tipo de metodología empleada, fue posible comprender el proceso de cui-

dado de los niños en una de sus dimensiones como es el cuidado a la salud, a través de las prácticas con el agua de consumo que realizan las madres.

Respecto a estas últimas, coincidiendo con Menéndez (1994), se sostiene que no existen grupos que carezcan de saberes de cuidado, y que la mayoría de estos criterios preventivos son socioculturales, por lo tanto, el punto central, no es tanto considerarlos como comportamientos erróneos o correctos, sino asumir que los grupos sociales producen criterios y prácticas de prevención más allá de que sean equivocados o no.

Las prácticas como el tratamiento de hervir, filtrar o la compra de agua embotellada que revelaron, a través de sus discursos las madres, están atravesadas, en su gran mayoría, por sus percepciones de riesgo (es decir, las creencias sobre el daño potencial) y la intención de llevarlas a cabo cuando marcaron una actitud positiva hacia su propio desempeño en las mismas y por la creencia que sus referentes sociales significativos, piensan que deberían realizarlas. (28 sobre un total de 35 madres que realizan algún tipo de práctica). Estos resultados se enmarcan en las predicciones del Modelo de la acción razonada de Fishbein y Ajzen.

Si bien no se han encontrado estudios sobre la misma temática, resultados similares registraron Álvarez y col (2004), Arreguín-Moreno y col. (2009) para los factores norma e intenciones, que se relacionan estadísticamente con una conducta proecológica, como es el cuidado del agua. (Álvarez, Moreno, Noriega, Moreno, y Valenzuela, 2004), (Arreguín-Moreno, Román-Pérez, Laborín-Álvarez, Moreno, Valdez, y Valenzuela, 2009).

El componente normativo de la intención de la conducta aparecería como determinantes en las tres madres (3/35), que si bien no perciben el riesgo llevan a cabo prácticas preventivas con el agua de consumo. Esta situación se puso en relieve en los grupos focales, donde la influencia de la percepción de la presión social determina dichas prácticas. (“familias”, “madres” “barrio”, “la doctora” etc.)

Siguiendo con estos enunciados, la decisión de no realizar ninguna práctica preventiva aun percibiendo el riesgo, se encontró como característica de otro grupo de madres (9/14). De estas madres, cabe destacar que cuatro de ellas, re-

firieron, tener una actitud positiva hacia tratar el agua de consumo. Esta aparente paradoja encontrada podría ser explicada, desde el sesgo optimista heurístico sobre la percepción de la posibilidad de enfermarse referida en el trabajo de Guedes y col (2015) que refiere a deficiencias cognitivas en la interpretación real del riesgo, en la extensión de los daños potenciales y la comprensión de los mecanismos de generación de los daños. Desde esta posición, en situaciones donde las personas creen tener un mayor control sobre sus acciones, la percepción de riesgo de contaminación es sistemáticamente subestimada. (Guedes, Simão, Dias y Braga, 2015).

Otra posible hipótesis sería sustentada en la confianza que le otorgan algunas madres al municipio en el suministro y distribución de agua apta para el consumo. En este sentido Doria y col. (2009) sugieren que uno de los factores que intervienen en la relación compleja entre las percepciones de la calidad del agua y el riesgo inherente a la salud, es la confianza en el proveedor de agua. (Doria, Pidgeon y Hunter, 2009)

La situación descrita anteriormente trae aparejada la idea de responsabilidad compartida de la calidad del agua consumida en el hogar. Se puede identificar en las narrativas de las participantes, que de alguna manera al decir de otros investigadores colocan a los dos polos de la relación (proveedor vs. consumidores) en un campo de juego nivelado, es decir, ambos lados son responsables de la calidad del agua. (Doria, Pidgeon y Hunter, 2009) (Carmo, Bevilacqua, y Barletto, 2015). Por otro lado, sería posible evidenciar la disponibilidad relativa de información necesaria para el proceso actitudinal en las 5 madres (5/14) del grupo anterior (que no realizan ningún tratamiento y no perciben el riesgo) ya que no referenciaron actitud positiva o negativo o que no emitieron juicio de valor. Según la teoría, el conocimiento antecede a las creencias y las actitudes y en este caso los saberes sobre calidad del agua, modos de tratamiento para la potabilización y enfermedades hídricas, parecerían ser lo fundante para la situación dada. En este sentido, las teorías de riesgo apoyan la importancia del conocimiento sobre las conductas preventivas en salud. (Arreguín-Moreno y col. 2009), (García Acosta, 2005)

Finalizando, los párrafos anteriores aportan algunas cuestiones que apoyan la idea principal de esta tesis que, desde las concepciones de la

salud familiar y comunitaria, el cuidado infantil y las prácticas maternas se construyen desde una mirada compleja y en la dialéctica de estratificación de la sociedad. Es así como toma importancia lo individual, lo comunitaria, el Estado y la comunidad de estados globalizados. (Samaja, 2014)

A modo de síntesis para repensar la salud de las infancias

En este trabajo se ha sostenido, desde la salud familiar y comunitaria con un enfoque desde la construcción social del riesgo, que las prácticas de cuidado con el agua de consumo para los niños se dan en una relación dialéctica entre las madres y la sociedad que se construye permanentemente. Esto es, las madres como sujetos sociales portan ideologías, valores, normas y creencias propias de los contextos donde han sido socializadas, y a su vez, que ellas reproducen y recrean ese contexto social donde transcurre sus vidas.

Desde las concepciones citadas anteriormente, se evidencia que los comportamientos de las madres no ocurren al azar ni en el vacío, sino que, a la luz de los hallazgos de la presente investigación, los mismos no pueden ser abordados desde un plano individual, sino como expresiones que ocurren en los escenarios socio ambientales cotidianos.

Los discursos y las imágenes recogidas de las madres que participaron de la investigación revelaron diversidad y contradicciones sobre las prácticas con el agua de consumo, así como, homogeneidades en algunos aspectos centrales de la tesis.

A través del conocimiento de la construcción social de percepciones sobre la calidad del agua del servicio ofrecido por el estado municipal, se pudo entender el significado de las prácticas, de modo de dibujar estrategias de educación para la salud que aborden la problemática de la diarrea infantil.

La participación de distintas instituciones y grupos sociales que directa o indirectamente contribuyen en el cuidado infantil, han quedado expuestos en los distintos fragmentos discursivos de las madres. Esta constelación de actores da cuenta de la complejidad del tema y del tipo de abordaje intersectorial que se necesita.

El Estado, a través de Obras Sanitaria Municipa-

pal, aparece como el principal proveedor del servicio de suministro de agua, y de él depende la calidad de ésta, asegurando su potabilidad. Sin embargo, queda claro que hay deficiencias en las formas de comunicación con la comunidad, respecto a las tareas que lleva a cabo para tal fin y a los valores de los indicadores de calidad del agua que debe respetar por ley. Esto hace pensar en la necesidad de revisar, los modos utilizados para transferir información a la población, en cuanto a los mensajes y los canales disponibles a nivel local.

En este sentido, es sabido que las campañas educativas no son suficientes y los espacios de reflexión con participación de la comunidad son escasos. Teniendo en cuenta, además, que las normas de calidad y la implementación de nuevas tecnologías para el mejoramiento del suministro de agua potable, requiere del acompañamiento y desarrollo de estrategias que permitan un dialogo entre los servicios de agua y las comunidades.

Por lo tanto, las autoridades deberían poner énfasis en transmitir información sobre el servicio a sus usuarios, con el fin de construir confianza y garantizar que el agua recibida en los hogares es de la calidad adecuada. La falta de información puede generar desconfianza y conceptos erróneos, mientras que la transferencia de conocimiento puede llevar a una mayor participación de la comunidad en la gestión de servicios de agua y el desarrollo de prácticas aceptables.

Siguiendo con el tema, en esta investigación, las características del agua asociada con los mecanismos sensoriales fueron relevantes, y han interferido con la aceptabilidad y el consumo del agua suministrada por el sistema público. Por ende, será crucial para la planificación de los servicios de suministro de agua y la vigilancia de la calidad del agua potable, el diálogo con la comunidad.

En concordancia con lo anterior, el consumo de agua embotellada se constituyó en una de las elecciones del agua para el consumo de los niños, con las implicaciones que trae aparejada desde las concepciones de salud infantil.

En este caso, será una problemática para re-trabajar en forma conjunta desde el Sistema de Salud en base a los lineamientos de una política de educación para la salud, priorizando la participación de las familias y comunidad. La incor-

poración en la planificación de estrategias de los medios de comunicación locales será oportuna y deseable.

Por otro lado, se ha evidenciado que el propio Sistema de Salud tiene incidencia en las intenciones de realizar las prácticas preventivas con el agua de consumo para los niños. De modo que, este reconocimiento, por parte de las madres, como norma subjetiva de la práctica, podría resultar un nexo virtuoso para implementar estrategias para los cuidados de salud infantil.

Por todo lo dicho, este estudio deja ver, que, en términos de impacto a la salud, son igual de importantes los cuidados que las madres tienen sobre el agua de consumo como la eficiencia y calidad del suministro. En otras palabras, no basta con tener una distribución de agua entubada de buena calidad, ya que los usos y tratamientos que ellas tengan sobre este recurso en sus hogares podría potenciar los riesgos a su salud.

En este sentido el acceso a la educación en salud juega un papel importante en la transmisión de los conocimientos necesarios para un manejo adecuado del recurso.

Acerca de esta aseveración, es posible, pensar en la dimensión cognitiva de las percepciones o creencias que las madres han relatado para repensar como punto de partida de toda intervención. Es así que se han podido reconocer como fuente de información, entre otras, a las experiencias personales directa, las tradiciones familiares y la información obtenida de otras personas del barrio y de las instituciones, las familias y los centros de salud.

Como consideración final y a modo de revisión de las políticas públicas a través de las instituciones del Estado, sería loable poner en el centro de la atención, a la familia y la comunidad como espacios de trabajo privilegiados para el fortalecimiento de aquellas estrategias, que ponen énfasis en las formas de cuidado y salud de las infancias.

Desde la producción de conocimiento científico, los hallazgos de esta tesis han puesto de manifiesto y enriquecen el estado actual de la cuestión, en el sentido de la complejidad del tema donde las perspectivas predominantes biomédicas y epidemiológicas de los riesgos a la salud y el cuidado, no resuelven por sí solas la cuestión de la relación entre el agua y las diarreas infantiles.

Futuras investigaciones podrán dar luz, a algunas hipótesis que quedaron plasmadas en el documento, desde un enfoque de construcción social del riesgo y las condiciones de vida como parte integral de la salud ambiental.

Bibliografía

- Ajzen, I.; Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Álvarez, J. F. L., Moreno, A. C., Noriega, J. Á. V., Moreno, R. H. A., & Valenzuela, B. A. (2004). Prácticas de consumo y actitudes hacia el cuidado del agua en habitantes de una zona urbana. *Psicología y Salud*, 14(2), 189-194.
- Arellano, E., Camarena, L., Von Glascoe, C., & Daesslé, W. (2009). Percepción del riesgo en salud por exposición a mezclas de contaminantes: el caso de los valles agrícolas de Mexicali y San Quintín, Baja California, México. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 27(3), 291-301.
- Arreguín-Moreno, R. H., Román-Pérez, R., Laborín-Álvarez, J. F., Moreno, J. L., Valdez, E. A., & Valenzuela, B. (2009). Factores psicosociales relacionados con el consumo doméstico de agua en una región semidesértica. *Salud pública de México*, 51, 321-326.
- Bain, R., Cronk, R., Wright, J., Yang, H., Slaymaker, T., & Bartram, J. (2014). Fecal Contamination of drinking-water in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *PLoS medicine*, 11(5).
- Benez, M. C., Kauffer Michel, E. F., & Álvarez Gordillo, G. D. C. (2010). Percepciones ambientales de la calidad del agua superficial en la microcuenca del río Fogótico, Chiapas. *Frontera norte*, 22(43), 129-158.
- Brewer, N. T., Chapman, G. B., Gibbons, F. X., Gerrard, M., McCaul, K. D., & Weinstein, N. D. (2007). Meta-analysis of the relationship between risk perception and health behavior: The example of vaccination. *Health Psychology*, 26(2), 136-145.
- Carabias, J., Landa, R., Collado, J. y Martínez, P. (2005) Situación mundial del agua. *Agua, medio ambiente y sociedad*. 85(1), 78-79.
- Carmo, R. F., Bevilacqua, P. D., & Barletto, M. (2015). Social representations of drinking water: subsidies for water quality surveillance programmes. *Journal of water and health*, 13(3), 671-679.
- Colangelo, M. A. (2012). La crianza en disputa: medicalización del cuidado infantil en la Argentina, entre 1890 y 1930 (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias Naturales y Museo).
- Corral Verdugo, V., Frías Armenta, M., & González Lomelí, D. (2003). Percepción de riesgos, conducta proambiental y variables demográficas en una comunidad de Sonora, México. *Región y Sociedad*, 15(26), 49-72.
- Chen, H., Zhang, Y., Ma, L., Liu, F., Zheng, W., Shen, Q., Qu, W. (2012). Change of water consumption and its potential influential factors in Shanghai: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 12(450).
- Doria, M. F. (2006). Bottled water versus tap water: understanding consumers' preferences. *Journal of water and health*, 4(2), 271-276.
- Dupont, D., y Krupnick, A. (2010). Differences in water consumption choices in Canada: the role of socio-demographics, experiences, and perceptions of health risks. *Journal of Water and Health*, 8(4), 671-686.
- Dupont, D. P. (2004). Do children matter? An examination of gender differences in environmental evaluation. *Ecological Economics*, 49(3), 273-286.
- Durán, R. A., Durán, E. L., Ojeda, G. D. J., & Castellanos, W. A. (2017). Distribución geográfica de fluoruros en el agua de red de abastecimiento público en la provincia de Tucumán, Argentina. *Salud colectiva*, 13, 105-122.
- Fernández, C. E., Giacaman, R. A. y Cury, J. A. (2014). Concentración de fluoruro en aguas embotelladas comercializadas en Chile: importancia en caries y

- fluorosis dental. *Revista médica de Chile*, 142(5), 623-629. García Acosta, V. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. *Desacatos* (19), 11-24.
- García del Castillo, J. (2012). Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las adicciones. *Salud y drogas*, 12(2), 133-151.
- Guedes, G. R., Simão, A. B., Dias, C. A., & Braga, E. D. O. (2015). Risk of contamination from exposure to Rio Doce water: a case study on the population's perceptions in Tumiritinga, Minas Gerais State, Brazil. *Cadernos de saúde pública*, 31(6), 1257-1268.
- Hobson, W. L., Knochel, M. L., Byington, C. L., Young, P. C., Hoff, C. J., & Buchi, K. F. (2007). Bottled, filtered, and tapwater use in Latino and non-Latino children. *Archives of pediatrics & adolescent medicine*, 161(5), 457-461.
- Hu, Z., Morton, L. W., & Mahler, R. (2011). Bottledwater: United States consumers and their perceptions of water quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(2), 565-578.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: Total del país y provincias: resultados definitivos. Variables seleccionadas [CD-ROM]. Buenos Aires: INDEC
- Jones, A. Q., Dewey, C. E., Dore, K., Majowicz, S. E., McEwen, S. A., Waltnr- Toews, D., Henson, S. & Mathews, E. (2007) A qualitative exploration of the public perception of municipal drinking water. *Water Policy* 9(4), 425-438.
- Ley N° 18284. Código Alimentario Argentino, las disposiciones higiénico- sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado por Decreto 141/1953.
- Méndez-Castellano, H. & Mendez, M. C. (1994). *Sociedad y estratificación. Método Graffar – Mendez Castellano*. Caracas: Ed. Fundacredesa
- MSN (2011) *Guías para la prevención y tratamiento de la Diarrea Aguda*. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Buenos Aires 2011.
- Moreno Zavaleta, M.T. (2003). *Percepciones y prácticas del manejo y uso del agua y su relación con la salud de los niños*. Análisis de experiencias en familias con diferentes tipos de abastecimiento de agua. Parte baja de la cuenca del río Lurín (Master's thesis, Lima, Perú: FLACSO Sede Ecuador: Colegio Andino.
- Morua, A. R., Halvorsen, K. E., & Mayer, A. S. (2011). Waterborne disease-related risk perceptions in the Sonora River Basin, Mexico. *Risk Analysis: An International Journal*, 31(5), 866-878.
- Mozobanczyk, S. y Pérez Sobrero, J. A. (2016). Percepción de la contaminación ambiental y los riesgos para la salud en la comunidad de "Villa Inflamable". *Anuario de Investigaciones*, 23(2).
- Myers, R. (1993). Los doce que sobreviven: fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera infancia en el Tercer Mundo. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.
- Ortales, S. y Santos, J. (coord.) (2014). *Crianza. Un estudio de los patrones de crianza en el partido de La Plata*. Buenos Aires: El Aleph.
- Ortale, S. (2015). *Acerca de la crianza. Reflexiones sobre el bienestar infantil*. *Pediatría en Red. Portal de Educación Permanente en Pediatría*, 116-120.
- Prieto, M. N., & Del Pozo, O. M. (2006). *Dinámica del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Coronel Suárez. Significatividad y disfuncionalidades*. *Revista Universitaria de Geografía*, 15.
- Pruess-Ustun, Annette & World Health Organization. (2008). *Safer water, better health: costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health*. / Annette Pruess-Ustun ... [et al]. World Health Organization.
- Saleh, M., Ewane, E., Jones, J. & Wilson, B. (2001) *Chemical evaluation of commercial bottled drinking water from Egypt*. *J. Food Compos. Anal.* 14(2), 127-152.
- Samaja, J. (1992). *La combinación de métodos: pasos para una comprensión dialéctica del trabajo interdisciplinario*. *Educación Médica y Salud (OPS)*, 26(1), 4-34. (2004). *Epistemología de la salud*. Buenos Aires: lugar editorial.
- Santillán, L. (2010). *Las configuraciones sociales de la crianza en barrios populares del Gran Buenos Aires*. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud*, 8(2), 921-932.
- Soares, A. C. C., Carmo, R. F., & Bevilacqua, P. D. (2017). *Saberes sociais e a construção da preferência pela água de consumo humano*. *Ciência & Saúde Coletiva*, 22, 3215-3223.
- Sociedad Argentina de Pediatría, (2006) *Flúor y prevención de caries en los niños*. *Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria*. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Stefani, D. (2005). *Teoría de la Acción Razonada: Una propuesta de evaluación cuali-cuantitativa de las creencias acerca de la institucionalización geriátrica*. *Revista Evaluar*, 5(1).

*Lic. Valeria Andrea Belmonte

Lic. en Salud Ambiental (UNER). Mg. en salud familiar y comunitaria (UNER). Docente investigadora extensionista de la cátedra Ordenamiento territorial de la Lic. en salud ambiental. Facultad de Ciencias de la Salud UNER.

**Lic. Liliana Mingillo

Lic. en Ciencias Bioquímicas (UNLP) Mg. en salud familiar y comunitaria (UNER). Docente investigadora extensionista del grupo Salud y Ambiente de la facultad de Ciencias de la Salud UNER. Coordinadora de la maestría salud familiar y comunitaria (UNER)

***Dr. Jorge Luis Pepe

Médico (UNLP). Mg en salud familiar y comunitaria (UNER). Docente investigador extensionista del grupo Salud y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Salud UNER. Director de la maestría salud familiar y comunitaria (UNER). Vicepresidente del Foro Argentino de facultades y escuelas de medicinas públicas (FAFEMP)

SEMIOLÓGIA FAMILIAR



PROF. DR. ADALBERTO ENRIQUE PALAZZI*

“Las cosas vivas tienden a unirse, a establecer vínculos, a vivir unas dentro de las otras, a regresar a ordenamientos anteriores, a coexistir cuando es posible. Es el curso del mundo”.
Lewis Thomas

Introducción

El pediatra, médico de familia de niños y adolescentes, el generalista, el clínico general, el médico de familia, al ser consultado por síntomas en niños y adolescentes, tiene la posibilidad de considerar como paciente a toda la familia, ASISTE A LA FAMILIA.

Reconoce las diferentes maneras de interacción, su relación con los síntomas, vinculados al contexto donde ocurren las distintas maneras de vivir en grupo actualmente.

Considerar la familia como una unidad de transformación interaccional facilita el entendimiento de las conductas que originan consultas, resultante de una simultaneidad de acciones compartidas de por lo menos tres generaciones, permitiendo una mayor coparticipación entre sus integrantes en la atención primaria de la salud.

Conocer las interacciones familiares orienta clarificando las preguntas para conocer la estructura, comprender el funcionamiento y ubicar el estadio del ciclo vital de la familia.

Incorporar información sobre dinámica familiar en el contexto donde se desarrolla, otorga la posibilidad de conocer los problemas de relación y ejercitar las distintas maneras de ofrecer ayuda en sintonía con la vida, ante la solicitud efectuada.

Usar los instrumentos adecuados permite recoger información sobre los modos relacionales transgeneracionales de las familias, sus reglas y

las redes sociales que las sostienen.

Para poder desarrollar este modo cotidiano de interacción entre familia, pediatra y niño sintomático, se hace necesario incorporar información específica sobre teoría de la comunicación humana, sistemas generales, sistemas humanos, sociología, antropología, ecología, etc.

Contenidos

La familia es la unidad social más pequeña, se modifica constantemente y simultáneamente mantiene una continuidad suficiente para la educación de sus hijos proporcionando firmes raíces para crecer, desarrollar y adaptarse. Es el contexto natural para recibir ayuda, un grupo esencial que elabora pautas de interacción en el tiempo, constituyendo las estructuras que rigen el funcionamiento de los integrantes de la familia, definiendo su gran variedad de conductas y posibilitando su interacción recíproca.

El pediatra tiene la posibilidad de acompañar a la familia durante un lapso prolongado y observarla como un organismo que evoluciona en el tiempo, sometida a las demandas de cambio de adentro (ej.: fallece el abuelo) o de afuera (inundaciones, crisis sociales). Los cambios que se suceden son la norma; revelan la notable flexibilidad, fluctuación constante y muy probablemente más desequilibrios que equilibrios en las familias observadas.

El considerarlas funcionando como un sistema vivo interaccional abierto, flexible en continua transformación, posibilita comprender los cambios que se suceden durante los distintos períodos de su ciclo vital.

Los componentes del grupo y sus atributos personales, junto con la interacción permanen-

te constituyen el sistema familiar, donde la totalidad es mayor que la suma de las partes, y también es menos si las partes no adquieren el máximo de su desarrollo y posibilidades.

Cada integrante del grupo familiar debe cumplir con sus funciones, adecuándolas a los momentos de crisis (crisis significa cambio y oportunidad).

Funciones de la familia para el crecimiento y desarrollo del niño

En forma general, estas son las de apoyar el desarrollo de las necesidades que tiene cada miembro del sistema. Según Erick Fromm, estas necesidades específicamente humanas son la necesidad de trascendencia, de identidad, de arraigo, de estructuración que oriente y vincule. Son propias de la especie, el ser humano las necesita para poder sobrevivir como el individuo biológico, emocional y social que es. Su común denominador es la posibilidad de ser descubiertas, ampliadas o reforzadas por los adultos que por lo general son padre y madre. Ackerman menciona seis funciones básicas que la familia debe llenar:

1. Satisfacer las necesidades materiales de alimentación, protección, y abrigo.
2. Ser la matriz de las relaciones interpersonales y afectivas.
3. Favorecer el desarrollo de la identidad individual ligada a la identidad familiar.
4. Facilitar el proceso de identificación sexual y papeles sexuales masculino o femenino.
5. Permitir el desarrollo social con el medio extrafamiliar.
6. Estimular el aprendizaje y desarrollo de la creatividad.

Estas consideraciones permiten sostener la importancia del sistema familiar, como fuente donde se satisfacen las necesidades del ser humano, contando con figuras de afecto, apoyo y seguridad.

El principio y fin de la familia es en concreto amar, educar y procurar el desarrollo de la pareja y de los hijos. Con ellos la misión estará cumplida al ayudarlos a transformarse en adultos sanos, como Stone describe al adulto:

“Aquel ser humano con capacidad para una verdadera madurez, quien ha superado la niñez sin perder las mejores características de esta. Que ha retenido los poderes emocionales bási-

cos de la infancia, la obstinada autonomía de la deambulación, la capacidad de sentirse integrado, el placer y el espíritu juguetón de los años escolares, idealismo y pasión de la adolescencia, habiendo incorporado todo ello a su nueva pauta de desarrollo dominada por la estabilidad, la sabiduría, el conocimiento, la sensibilidad hacia los demás, la responsabilidad, la fuerza y la determinación de la edad adulta”. (“La Familia”, del Dr. E. Dulanto Gutiérrez).

Veamos una manera de evaluar el grado de funcionalidad de la familia según Virginia Satir:

1. En su comunicación: en una familia funcional la comunicación es clara, directa, específica, congruente. En una familia disfuncional, la comunicación es oscura, indirecta, inespecífica e incongruente.

2. En la individualidad: la autonomía de sus miembros se respeta en la funcional, y las diferencias individuales no solo se toleran, sino que se estimulan para favorecer el crecimiento individual de cada uno y del grupo familiar.

3. En la toma de decisiones: la búsqueda de la solución más adecuada para cada problema es más importante que la lucha por el poder. En una familia disfuncional, el aspecto más importante es quién va a salirse con la suya, y como consecuencia los problemas tienden a no ser resueltos porque nadie quiere perder.

4. La reacción ante las demandas de cambio: un sistema familiar funcional es lo suficientemente flexible para cambiar cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que se puede conservar la homeostasis sin que alguno de los miembros desarrolle síntomas. En una familia disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio favorecen el desarrollo de psicopatologías (angustia, depresión, trastornos de conducta) cuando las demandas amenazan con romper la homeostasis. Según este enfoque, se considera que el paciente identificado ha sido llevado por sus familiares a asumir el papel de enfermo, y que su enfermedad desempeña funciones hemostáticas en la familia.

La dinámica familiar funcional o disfuncional es infinitamente compleja. Hay variaciones caledoscópicas que pueden producir salud o enfermedad.

Los modelos en ciencia tienen una función similar a la que tiene el mapa para el geógrafo o el viajero, son diagramas, pero no es el territo-

rio. Son herramientas para pensar que permiten una simplificación y agregan orden a una realidad compleja. El paradigma estructural sistémico está sostenido por los aportes de la teoría de los sistemas generales.

Nos permite pensar a la familia como si fuera un sistema, es decir, un conjunto de objetos y de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, donde los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unido al sistema (Hall, Fagen, Watzlawick).

Axiomas de la comunicación humana

Es sumamente útil conocer los axiomas básicos exploratorios de la comunicación humana, para conocer la estructura y organización familiar, y aplicarlos en la relación familia-pediatra-niño. Se sostiene que toda conducta es comunicación, y un mensaje es cualquier unidad comunicacional (conducta) y por interacción la serie de mensajes intercambiados entre personas.

El 1° axioma de la comunicación expresa: NO ES POSIBLE NO COMUNICARSE.

2° axioma: TODA COMUNICACIÓN TIENE UN ASPECTO DE CONTENIDO Y UN ASPECTO RELACIONAL, TALES QUE EL SEGUNDO CLASIFICA AL PRIMERO Y ES POR ENDE UNA META COMUNICACIÓN.

3° axioma: LA NATURALEZA DE UNA RELACIÓN DEPENDE DE LA PUNTUACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS COMUNICANTES.

4° axioma: LOS SERES HUMANOS SE COMUNICAN TANTO DIGITAL COMO ANALÓGICAMENTE.

El lenguaje digital es la palabra, el analógico son los gestos, la inflexión de la voz, etc. El hombre es el único organismo que utiliza ambos.

Características del lenguaje	
digital	analógico
sintaxis (la palabra)	semántica (significado)
contenido	relación
discontinuidad	continuidad
tiene negativo	no tiene negativo
signo arbitrario: palabra:	gestos
comunicación verbal	comunicación no verbal

5° axioma: TODOS LOS INTERCAMBIOS COMUNICACIONALES SON SIMÉTRICOS O COMPLEMENTARIOS, SEGÚN ESTÉN BASADOS EN LA IGUALDAD O EN LA DIFERENCIA.

Una conducta autoritaria promueve una conducta de sometimiento y esta última promueve, a su vez, una conducta autoritaria = interacción complementaria.

Una conducta determinada puede ocasionar una situación competitiva cuya respuesta es una conducta similar al estímulo = interacción simétrica.

Con estos conceptos básicos aprendidos, podemos considerar EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA. Como señalara anteriormente, la familia es la unidad natural de supervivencia del ser humano. Recorre un proceso evolutivo de desarrollo, y surgen en su transcurso una serie de cambios o modificaciones que exigen de sus integrantes una adaptación y redistribución de las funciones, siendo funcional o disfuncional, sea que lo logre o no.

a. Formación de la pareja y comienzo de la familia, convivencia o matrimonio.

b. Etapa de crianza inicial de los hijos.

c. Familia con hijos en escolaridad.

d. Familia con hijos adolescentes.

e. Familias con hijos jóvenes.

f. Familias con hijos jóvenes que se separan y continúan su ciclo vital.

g. Pareja (síndrome del nido vacío).

h. Vejez, senectud, abuelitud, muerte.

La familia, a medida que transcurre su ciclo vital, va de la totalidad a la independencia.

El crecimiento y desarrollo, por sí solos, implican segregación, pero al mismo tiempo tendencia a la sistematización. Hay un enriquecimiento de la red interna de la familia. Como grupo humano con historia que evoluciona en contexto, va coordinando su accionar, en consenso y disenso, conviene normas y reglas propias que regulan sus interacciones. Es un modo de concebir la realidad, el estilo familiar, sus códigos, conceptos, premisas compartidas a partir de las cuales “construye” la realidad, compartiendo una visión de la historia común. Conocer las crisis, las conductas consecuentes, facilitan al pediatra interaccionar y poder ayudar como factor de cambio, generando oportunidades, para que puedan continuar evolucionando.

En la consulta, la inspección de la familia per-

mite observar el modo de comunicación no verbal, quiénes están presentes, cómo se acomodan o se sientan, manera de vestir, condiciones de higiene, formas de desplazarse, expresiones, modificaciones posturales, cercanía, proximidad, distancia. La palpación, el saludo adecuado al contexto sociocultural, manera de estrechar la mano, firmeza, vacilación, timidez, miedo, confianza, desconfianza. La auscultación es el resultado del modo de comunicación verbal al utilizar el lenguaje, cómo, para qué, qué dice, presentación, identificación, activo, pasivo, quién responde por todos, quién autoriza a hablar, etc. La percusión deriva de la interacción estratégica, y las respuestas que surgen de acuerdo con la intensidad del estímulo, visualización de alianzas coaliciones, mimetismos, escultura familiar, etc. Favorece el contacto íntimo, intenso, respetuoso, priorizando lo registrado a través de un pensamiento disciplinado con dignidad humana, logrando un corrimiento de la causalidad lineal del porqué a la causalidad circular del para qué, constituyéndose por sí mismo en un acto terapéutico el encuentro con la familia.

EL USO DEL GENOGRAMA EN LA SEMIOLOGÍA FAMILIAR

El genograma es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos tres generaciones, y se amplía en ocasiones a cuatro generaciones al registrar embarazos en adolescentes.

Son representaciones tangibles y gráficas de una familia, que proporcionan una rápida visión global de complejas normas familiares, y una rica fuente de hipótesis sobre cómo un problema clínico puede estar relacionado con el contexto familiar y la evolución, tanto del problema como del contexto, a través del tiempo. La interpretación de los genogramas se efectúa sobre la base de la teoría de los sistemas generales y los sistemas humanos. Se aplica en el reconocimiento de la estructura, organización, funcionamiento y ciclo vital de la familia. Es una herramienta interpretativa subjetiva.

Situación clínica

El pediatra recibe a la familia, se presenta, saluda estrechando la mano a los adultos, con un beso a los niños. Emanuel lo evita, la hermana lo

acepta, la familia da a conocer sus nombres, los chicos inmediatamente comienzan a jugar con los juguetes del consultorio (identificación, intercambio personalizado).

Motivo de consulta: consultan por Emanuel. Están preocupados por tres cosas:

1. Las dificultades de Emanuel para integrarse con los chicos de su edad. Relatan, como episodio más saliente, la negativa a salir a la cancha para jugar un partido de fútbol con espectadores, pese a que le gusta jugar a la pelota. La madre insistía en que fuera a jugar, el padre aceptó que no lo hiciese y se quedó en el vestuario con él.

2. Que solo acepta que el padre lo ayude a cambiarse luego del baño, no quiere mostrarse desnudo ante la madre y la hermana. La madre lo relaciona con un acontecimiento ocurrido a los dos años y medio, en que un primo de 7 años, delante de toda la familia, le baja los pantalones desde atrás, provocándole una crisis de bronca, con llantos y gritos, y fue necesario mucho esfuerzo para tranquilizarlo.

3. Están preocupados por saber si los efectos secundarios de un antihistamínico que toma diariamente por la prescripción del dermatólogo, por reacciones alérgicas cutáneas, tiene relación con la conducta. Refieren que es alérgico desde los primeros meses, con rinitis e infecciones respiratorias recurrentes, y que es tratado por alergista.

Genograma familiar

Emanuel, 5 años. María, 2 años.

Residentes en un pueblo vecino, familia de agricultores, se casan luego de cinco años de novios y viven en el campo, en la casa de los padres de Néstor, cuatro años mientras construyen su casa en el pueblo. Durante ese tiempo nace Emanuel, luego un aborto espontáneo por placenta previa, y comienza el embarazo de María Belén, que nace viviendo en la casa propia. Al comentar que debió ser difícil iniciar su convivencia en casa de los padres de Néstor, tal vez más complicado para ella, manifiesta estar de acuerdo y refiere que eran dos formas totalmente diferentes de vivir y de ser las de las dos familias; menciona un sometimiento del esposo a las decisiones del padre. El desarrollo y examen físico de Emanuel son normales. El pediatra expresa sus puntos de vista respecto a sus

interrogantes y, sin descalificar la prescripción del colega, enfatiza la condición de sano del niño sintomático; se efectúan acciones educativas con relación a la conducta que les preocupa. El seguimiento muestra la desaparición de las conductas preocupantes, negocian mejor sus puntos de vistas diferentes, no se pelean por sus familias de origen y están cursando un nuevo embarazo.

1. ¿Qué problemas identifica en esta familia?
2. ¿Qué consideraciones puede hacer sobre la funcionalidad de la familia?
3. ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentra esta familia?
4. ¿Qué apreciaciones puede efectuar sobre la estructura y organización familiar?
5. ¿Qué consideraciones le sugiere el proceso de ayuda ofrecido a la familia?

Comentarios

Los padres consultaron durante estos cinco años a especialistas en alergia por las recurrencias respiratorias y dermatológicas en Emanuel. La presencia de un niño muy sensible y altamente perceptivo muestra cómo los síntomas cumplen función hemostática en la familia. Las dificultades en relación con jugar en público, como así también las expresadas en el área de su sexualidad, son habituales a esta edad. Serán muy valiosas las tareas educativas al respecto en las ocasiones que se presenten.

La familia presenta una disfunción funcional mínima. El padre, que viene de una familia muy aglutinada, tiene dificultades para separarse de su familia de origen y acentúa más la dificultad el hecho de que trabaja con el padre. La madre proviene de una familia más desligada, por lo que ha podido transitar su separación con límites claros. Tiene dificultades en la organización, pues su estructura es rígida; tiene dificultades para superar las crisis y para negociar las diferencias; acuerdan en el contenido, pero no acuerdan en la relación.

La familia se encuentra en la etapa de tener hijos pequeños, e hijos pequeños que comienzan su escolaridad. Se amplió el contacto con el contexto familiar a través de la institución escolar. Se planteó la posibilidad de efectuar una hipótesis del juego relacional de esta familia, de las dificultades con sus familias de origen; acordando con ella, se efectúan esclarecimientos

educativos que pueden implementar a través de luchar juntos y no por el poder absoluto. Explicitado el juego relacional interaccional transgeneracional, manifestando los padres acuerdo, se efectúan tres reuniones educativas que favorecen el cambio. Actualmente, con dos hijos más, continúan juntos, negociando sus diferencias, creciendo como grupo familiar.

Conclusiones

Conocer la estructura, la organización, el funcionamiento y la etapa del ciclo vital facilita la comprensión de la situación clínica y permite adecuar más eficazmente el recurso de ayuda.

La inclusión del genograma en la historia clínica en todos los niveles de atención, la posibilidad de recurrir al apgar familiar, y al círculo familiar cuando es oportuno, afianza la relación médico-paciente. Facilita la cooperación del grupo en las acciones terapéuticas, habilita a reflexionar sobre las propias vivencias a partir del conocimiento de otros modos de vivir, promoviendo un crecimiento personal más amplio y jerarquizando la condición humana del encuentro.

El pediatra, el médico generalista, el de familia, entendiendo el proceso de salud-enfermedad como una sucesión de interacciones contextuales dinámicas en totalidad, en el transcurso de la vida, puede observarse como ser humano comprometido con los demás seres humanos que integran las familias, evitando prácticas, derivaciones e internaciones innecesarias.

Resulta un factor que promueve el trabajo transdisciplinario, jerarquizando la totalidad y la interacción relacional de las partes.

A MODO DE SÍNTESIS

“Las raíces profundas del bienestar de la infancia no han estado ni estarán en la pediatría convencional, sino en las familias sanas y vigorosas, diligentes y enriquecidas mediante lazos de comprensión y amor, bien insertas en el medio social”.

“El pediatra que no educa a sus pacientes y familias, que no detecta riesgos y capacidades y que por lo tanto no previene ni promueve, el que no supervisa el crecimiento y desarrollo del niño y su entorno, aquel que solo busca enfermedades, terminará por imaginarlas, o crearlas”.

“Los pediatras tenemos labores que cumplir, cerca de las familias argentinas, repitiendo una

y otra vez los gestos esenciales de nuestra profesión: AYUDAR, CURAR TAL VEZ...". Dr. Carlos A. Gianantonio

"El principal error es creer que uno cura al paciente, cuando en la mayoría de las situaciones solo deberíamos ser pacientes para esperar la cura, sin crear el error". Dr. Juan Reichenbach.

Bibliografía

- Dulanto Gutiérrez E. y colab. *La familia, medio propiciador o inhibidor del desarrollo humano*. Impresora y Editora Mexicana. 1985
- Dulanto Gutiérrez E. y colab. *La familia, un espacio de crecimiento y encuentro para todos*. 2004.
- Dolto F. *La causa de los niños*. Paidós. 1991.
- Gianantonio C. *El médico y su paciente*. Temas de pediatría. Lab. Roche. 7/1980.
- Gianantonio C. *La medicina y el niño*. Pediatría. Lab. Geigy. N° 1 1982.
- Gianantonio C. *Problemas psicossomáticos en pediatría*. Lab. Roche 1980.
- Haley J. *Trastornos de la emancipación juvenil y terapia familiar*. Amorrortu E. 1985.
- McGoldrick M, Gerson R. *Genogramas en la evaluación familiar*. Gedisa, 1993.
- Minuchin S. *Familias y terapia familiar*. Editorial Gedisa. Barcelona 1979.
- Minuchin S., Fischman C. *Técnicas de terapia familiar*. Paidós, 1985.
- Minuchin S. *La recuperación de la familia*. Paidós. 1994.
- Palazzi A. *Familias con niños asmáticos. Integración del pediatra en el proceso terapéutico*.
- Libro de Resúmenes. 29 Congreso Argentino de Pediatría. Río Hondo. Mayo 1991. N° 6394.*
- Palazzi A. Amelon G. *Programa de orientación familiar para el embarazo y recién nacido*. Temas pediátricos. Lib. Res. Conarpe 29. R. Hondo. Mayo 1991. N° 6393.
- Palazzi A. *Enfoque sistémico relacional para la consulta pediátrica en el consultorio externo e internación del hospital público*. Lib. Res. R. Hondo 29 Conarpe. Mayo 1991. N° 6395.
- Palazzi A. *Consejería familiar. Un aporte al crecimiento de la familia en la atención pediátrica*. Lib. Res. R. Hondo. 29 Conarpe. Mayo 1991. N° 6396.
- Palazzi A. *Sistemas humanos y comunicación. Su inclusión en un programa de residencia pediátrica privada en la ciudad de Rosario*. Lib. Res. 29 Conarpe. Mayo 1991. N° 6398.
- Palazzi A. *El pediatra junto a familias con enfermedades reumáticas*. Lib. Res. 29 Conarpe. Mayo 1991. N° 6397.
- Palazzi A. *El Genograma familiar en pediatría*. Lib. Res. VII simp, Ped. Soc. Salta abril 1996. N° 34.
- Palazzi A. *Los derechos de los niños en atención ambulatoria*. VII Simp. Ped. Soc. Salta abril 1996. Lib. Res. N° 176.
- Palazzi A. *El consejo pediátrico (consejería familiar)*. 31 Conarpe. Mendoza setiembre 1997. Lib. Res. N° 176.
- Palazzi A. *Semiología familiar*. 31. Conarpe. Mendoza setiembre 1997. Lib. Res. N° 177
- Palazzi A. *El Genograma familiar en la historia clínica pediátrica*. 31 Conarpe Mendoza. Setiembre 1997. Lib. Res. N° 266.
- Palazzi A. *Relación familia pediatra. Enfoque sistémico relacional interaccional en contexto*. 31 Conarpe. Mendoza setiembre 1997. Lib. Res. N° 267.
- Selvini Palazzoli M. *El desarrollo del niño desde el enfoque sistémico*.

*Prof. Dr. Adalberto Enrique Palazzi

Profesor titular Cátedra de Pediatría, UAI Rosario.
Ex profesor titular Cátedra de Pediatría de la UNR.

ABORDAJE PALIATIVO EN NEONATOLOGÍA: SUBJETIVANDO LO INNOMBRABLE



LIC. MARIANELA BALANESI*

LIC. CLAUDIA MÓNICA GARCÍA**

Se destaca la necesidad de seguir desarrollando los cuidados paliativos perinatales, desde el enfoque de derecho, se analizan los modelos de implementación de cuidados paliativos (CP), destacando la afinidad del enfoque integral de Milstein con los principios esenciales aplicables en CP, la importancia del abordaje prenatal. Se describen los neonatos con criterio de abordaje paliativo, la importancia de favorecer estos duelos culturalmente desautorizados y el rol de los profesionales de la salud a lo largo de las distintas etapas.

Quien conoce todas las respuestas, no se ha hecho todas las preguntas. Confucio

Acerca de la necesidad de ampliar nuestra mirada:

Si la atención de pacientes al final de la vida, ha sido, y sigue siendo un enorme desafío para el equipo de salud, el reto se hace aún más complejo cuando esta muerte ocurre prematuramente, tan pronto como en el instante del nacimiento, algunas horas, semanas o meses después. Desde una mirada bio-psico-social, el nacimiento representa el comienzo, nunca el final.

Según se ha descripto (Kiman, 2014) 1, los neonatos y bebés son quienes tienen la más alta tasa de mortalidad en la población pediátrica. A nivel global, y desde 1970, el número de niños que mueren anualmente ha descendido casi a la mitad. Aún así, tres millones de neonatos continúan muriendo cada año, lo que representa casi la mitad de las muertes de menores de 5

años alrededor del mundo. Las tres principales causas de muerte neonatal son las complicaciones durante el nacimiento, la prematurez y las infecciones. Más de un millón de niños mueren en el primer día de vida. El día del nacimiento es el de mayor riesgo para los bebés, prácticamente en casi todos los países, ricos y pobres (Save the Children, 2013).

En cualquiera de estos casos, se hace evidente el fracaso rotundo del tradicional abordaje exclusivamente curativo, llevado a cabo en instituciones pensadas para el tratamiento de enfermedades agudas, y en sociedades en las cuales la muerte en general y en especial la enfermedad o muerte de un bebé o niño son cuestiones tabúes, una experiencia traumática no solo para el niño y su grupo familiar, sino –de no empezar a impulsarse y fomentar saberes y acciones preventivas-, también para los profesionales de la salud que intervienen en esta instancia.

La pediatría del Siglo XXI nos está enfrentando a grandes retos. Las patologías crónicas complejas irán incrementándose en proporción directa a los avances tecnológicos y científicos, de manera que la preocupación hará especial eje en aquellos aspectos vinculados a la calidad de vida y humanización de la asistencia. La supervivencia de los prematuros extremos irá en aumento también de la mano de la tecnología, no obstante, esto no parece ir de la mano de un descenso en la morbilidad e impacto en la calidad de vida, como veremos más adelante.

Enfrentarse al final de una vida que se trunca

en su inicio, advertir que establecer un límite de viabilidad es mucho más que una competencia entre tecnologías sofisticadas desde que está en juego la calidad de vida futura de un niño y la familia que habrá de cuidarlo, reconocer que aún en aquellas condiciones conocidas como ‘incompatibles con la vida’ el estándar de calidad de vida es prioritario, acompañar a las familias en aquellas patologías crónicas que limitan o amenazan la vida desde el momento en que se realiza el diagnóstico, durante el transcurso de la enfermedad, durante el final de vida y aún más allá, son los retos que se plantean en el contexto de lo que se conoce como el cuidado paliativo perinatal.

Todas las acciones que realicemos –como las que dejemos de realizar- en esta instancia, impactarán profundamente en la biografía de cada uno de estos niños y familias, obligadas a enfrentar al duro reto de lidiar con lo que no queremos ver ni nombrar.

CP como enfoque de derecho. Datos epidemiológicos

Los CP han sido categorizados como Derechos Humanos ‘per sé’. Incluirlos en esta categoría, permite “garantizar, a aquellos que padecen enfermedades terminales o patologías crónicas amenazantes o limitantes de la vida, el cuidado y atención integral que tal concepto supone y remarcando la responsabilidad en cabeza de los Estados de cumplir con sus obligaciones positivas para proveer de los medios y dispositivos adecuados que garanticen un acceso integral, universal y completo a los cuidados paliativos en todos los subsistemas de salud existentes” (Ciruzzi, 2019) 2.

Como es sabido, la mortalidad infantil tiene tres componentes según el momento en que esta ocurre: la muerte neonatal se subdivide en dos etapas: neonatal precoz o temprana (0 a 6 días), neonatal tardía (7 a 27 días). La muerte post neonatal es la acaecida entre los 28 días y hasta los 11 meses y 29 días.

Los tres componentes han ido en descenso desde 1990. No obstante, siguen siendo lo que se conoce como el ‘componente duro’ de la mortalidad infantil.

Gráfico 9. Tendencia de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal por 1000 nacidos vivos. Argentina, 1990 a 2017

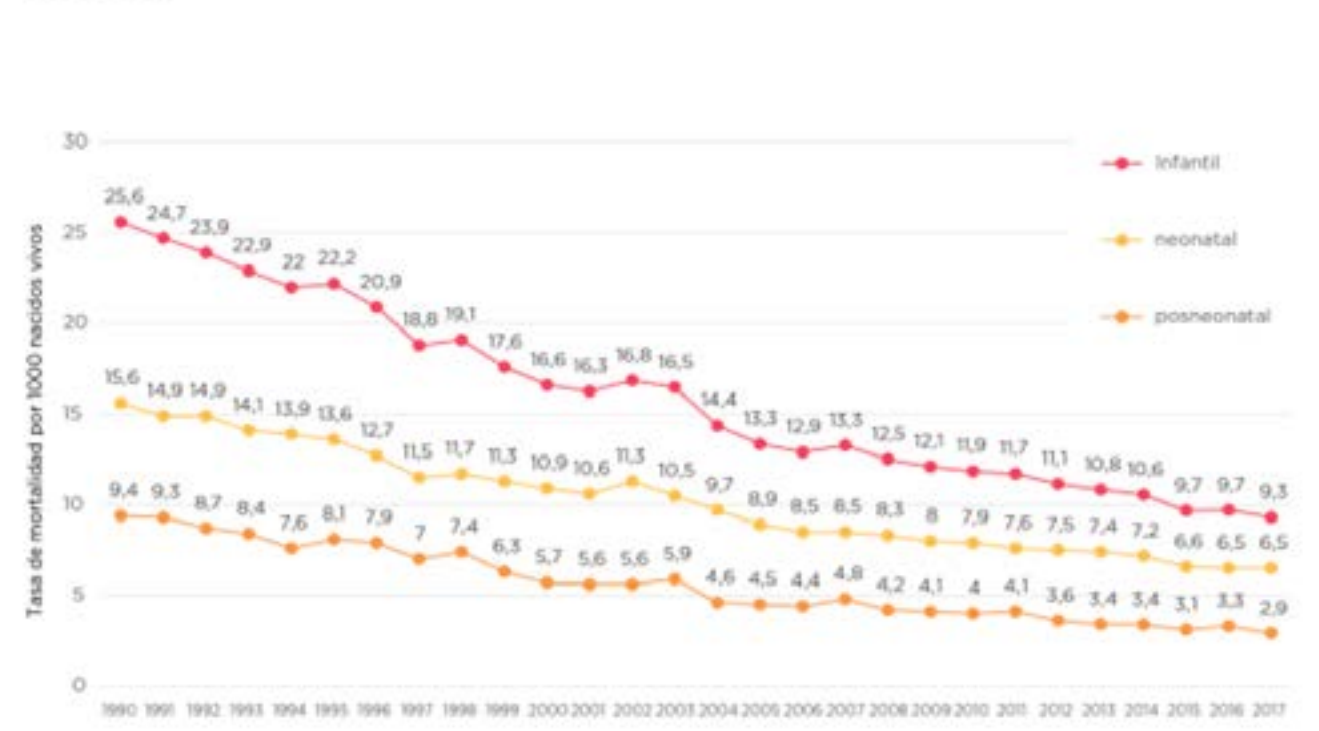


Tabla 1: Tendencia Mortalidad Infantil, neonatal y post neonatal por 1000 nacidos vivos. Fuente: UNICEF-SAP Salud Materno Infanto Juvenil en Cifras 2019

En 2018, un 1,1 % del total de nacidos vivos pesaron menos de 1500 gramos. Un total de 2142 de recién nacidos fueron prematuros extremos (nacidos entre la semana 24 a 27 de edad gestacional, lo que representa apenas un 0,3 por ciento del total de nacimientos), mientras que 5390 nacieron entre las semanas 28 y 31 de edad gestacional (un 0,78% del porcentaje del total de nacidos vivos).

Es sabida la relación existente entre estos dos indicadores (bajo peso y prematuridad) y la mortalidad infantil. Es sabido que la mortalidad neonatal temprana y tardía integran lo que se conoce como el 'componente duro' de la TMI.

Desglosando el número de defunciones de niños ocurridos durante el 2018, tenemos que de un total de 6048 muertes, 2490 ocurrieron en la primer semana de vida (0-6 días) representando un 48,6% del total, mientras que el resto se divide de la siguiente manera: 1181 (19,5%) clasifican como muertes neonatales tardías, y 1297 (31,8%) como post-neonatales. Estos son los números que reflejan lo que quiere decirse cuando se habla de ese componente duro de la TMI: el 68,1% de las muertes incluidas en la TMI corresponden a muerte neonatal temprana y tardía. Llevado a LA TMI 2018, de ese 8,8 por 10.000 muertes neonatales por 10.000 nacidos vivos ocurridos en Argentina en 2018, 4,3 cada 10.000 son muertes neonatales precoces, 1,7

tardías y 2,8 muertes post-neonatales.

Otra realidad que entra en juego, es que la tasa de supervivencia de los prematuros extremos (nacidos entre las semanas 24 y 28 de edad gestacional) y de los de extremo bajo peso al nacer (menos de 1000 gramos) ha ido aumentando también al ritmo del avance de la tecnología médica disponible según los recursos de cada país. Argentina presenta porcentajes de prematuridad y BPN similares a los países desarrollados, sin embargo, los resultados del cuidado neonatal son diferentes.

Sin embargo, esta mejora en la mortalidad no ha ido acompañada de la reducción en la morbilidad. Marlow et al (2005), mostraron que los niños nacidos con menos de 26 semanas son más propensos a sufrir secuelas cognitivas comparados con el resto de los prematuros. De hecho, la frecuencia de la DBP, sepsis, pobre crecimiento y desórdenes neurológicos ha ido en aumento. (Sebastiani y Ceriani Cernadas, 2008).

Como puede apreciarse en el gráfico abajo expuesto, la mortalidad desciende con el avance semana a semana en la edad gestacional al nacer, mientras que la supervivencia libre de morbilidad lo hace a la inversa. Nótese que solo el 6,4 por ciento de los nacidos con 24 semanas no desarrollaran ninguna morbilidad asociada y para las 31 semanas aún más de la mitad padecerán morbilidades asociadas a su prematuridad.

TABLA 2. Características demográficas, mortalidad y supervivencia libre de morbilidad neonatal de la población en estudio según semana de edad gestacional, Red Neocosur, 2001-2011

EG (sem)	n (%)	PN (g)	Sexo masculino %	Corticoides prenatales %	Mortalidad %	Supervivencia libre de morbilidad* %
24	540 (6,6)	698±131	57,5	63,6	71,4	6,4
25	643 (7,8)	761±134	52,0	76,9	53,3	10,3
26	806 (9,8)	849±169	54,8	75,9	41,1	20,1
27	1026 (12,5)	951±187	52,5	79,3	29,6	30,3
28	1334 (16,2)	1049±214	53,9	79,1	22,7	45,8
29	1319 (16,0)	1151±216	51,9	80,3	14,5	53,5
30	1522 (18,5)	1217±203	49,9	79,7	12,2	62,3
31	1044 (12,7)	1257±192	48,5	81,4	9,4	68,4
Total	8234 (100)	1046±262	52,2	78,2	26,0	47,3
Valor p		<0,001†		<0,001*	<0,001*	0,001*

EG: edad gestacional; PN: peso de nacimiento, se expresa como promedio ± DE.

* Supervivencia libre de RDP, DBP, HIV grave, LPV, ECN.

† Valor p calculado según la prueba de correlación de Spearman.

* Valor p calculado según la prueba de tendencia de Cochran-Armitage.

Características demográficas, mortalidad y supervivencia libre de morbilidad neonatal de la población en estudio según semana de edad gestacional, Red Neocosur, 2001-2011

Con estos números estamos queriendo reflejar dos grandes realidades por todos conocidas:

El impacto de la mortalidad neonatal en el TMI.

Que gran parte de esta mortalidad es reducible, a veces con acciones muy sencillas, y

El impacto en la morbilidad (y calidad de vida), de las intervenciones realizadas en nuestros recién nacidos, a menudo inevitables por la corta edad gestacional al nacer.

En cada uno de estos números hay infinidad de posibilidades y contextos variables. Si lo que queremos es subjetivar lo innumerable, es decir, contextualizar cada historia y ‘calificar’ (aportar calidad) sin cuantificar el impacto de nuestras acciones, los números no son de gran ayuda.

En nuestra reflexión, queremos aportar al enfoque tradicional de pensar: ¿qué podemos hacer para que no se mueran? – lo que sin duda, seguiremos trabajando paralelamente sobre todo en el enfoque preventivo-, otros tipos de interrogantes:

¿Podemos mejorar la calidad de estas vidas cuya duración oscila entre minutos, horas, a semanas (cortas, muy cortas a veces) hasta meses, o quizás, años?

¿Se puede ‘enriquecer’ sus vidas hasta que la muerte ocurra?

¿Podemos aportar compasión a la familia que enfrenta el acontecimiento del suceso innumerable muerte, ante el proyecto vital de un hijo?

La compasión implica “ponerse en el lugar del otro, de manera bondadosa, intentar “comprender la situación” y actuar con el otro del modo en que uno quisiera ser tratado en dicha situación” (Piccinini, 2018)³. La compasión atraviesa todas las prácticas de acompañamiento en los Cuidados Paliativos.

La especificidad del abordaje paliativo nos trae esta gran enseñanza y herramienta. Desde ya, traspolable a todas nuestras intervenciones. En definitiva, como pediatras, siempre tendremos enfrente nuestro, un otro atravesado por distintas ‘capas de vulnerabilidad’ (Luna, 2011)⁴

Modelos de implementación de cuidados paliativos

Los modelos de implementación de CP han ido cambiando conforme los paradigmas de abordaje en medicina. Allá por el siglo XVII, las teorías reduccionistas afirmaban que cuerpo y mente eran entidades independientes.

En 1977, Engels destacó que la enfermedad representa la personificación de factores biológicos, psicológicos y sociológicos. Michael Lerner expande esta distinción entre el modelo biomédico y el biopsicosocial para desarrollar una visión ampliada del cuidado, especialmente en pacientes con cáncer. Se distinguen aquí los conceptos de enfermedad/dolencia y curar/sanar: la enfermedad representa los elementos biológicos y orgánicos y el dolor asociado a los mismos, mientras que la dolencia implica la experiencia cognitiva, emocional y espiritual y el sufrimiento asociado. Curar es tratar los componentes orgánicos, mientras que sanar es abordar todos los componentes. Siguió luego los aportes de Arthur Kleinman, quien destacó la interacción entre la enfermedad, el paciente y la vida de sus familias, la importancia del duelo y el proceso de afrontamiento. En años más recientes, la práctica médica con competencias narrativas está comenzando a implementarse. La habilidad de responder a las “historias de los pacientes” está demostrando ser una parte crítica de la medicina efectiva y humanizada. (Milstein, 2005) ⁵.

El primer modelo de CP corresponde al paradigma biomédico, es el modelo “en serie”, es decir, los CP se instalan recién una vez que fracasan las medidas curativas. Este modelo fue superado por el modelo ‘en paralelo’, inicialmente pensado para patologías crónicas y pacientes con cáncer. Las medidas paliativas y curativas pueden implementarse a la par, sin excluirse, hasta el momento en que la muerte ocurre y sigue el duelo.

Un nuevo modelo, conocido como INTEGRAL, se propone desde la necesidad de abordar la experiencia humana de enfermedad, considerando a ese individuo como parte de una familia, y considerando que el duelo no se produce exclusivamente al ocurrir la muerte, sino que este se inicia con el diagnóstico de una enfermedad grave (y la pérdida de una vida ‘normal’ que esto implica). Se destaca aquí la importancia de cambiar nuestra concepción de “hacer” hacia una de ‘estar con’. Esta actitud de ‘estar con’ puede mejorar la experiencia de sanar y el sentido de conexión de todos los implicados: los pacientes, sus familias e incluso, los cuidadores.

El cuidado de neonatos enfermos, el contacto frecuente con patologías irreversibles, las situaciones de estrés y shock que se experimentan cuando el nacimiento transcurre con complica-

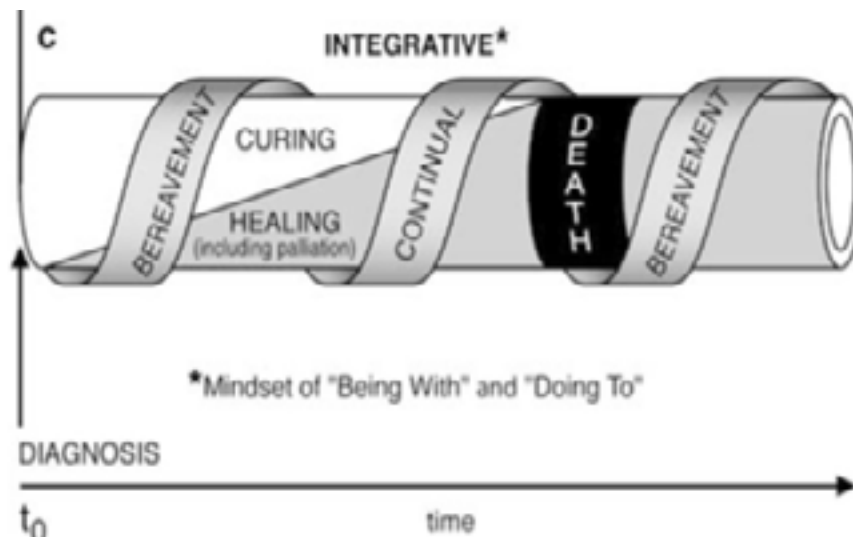


Gráfico ilustrando el Modelo de abordaje Integral. Fuente: Milstein, J. A Paradigm of Integrative Care: Healing with Curing Throughout Life, "Being with" and "Doing to"

ciones inesperadas, suponen una enorme carga para todo el equipo de salud. Los vínculos que se establecen con las familias suelen ser estrechos ya que los períodos de internación pueden ser prolongados. La vulnerabilidad de los profesionales que desarrollan su tarea en este ámbito es evidente.

Por ello, es muy necesario estar especialmente atentos a la aparición del Síndrome de 'Burnout', que fue definido como ese "estado caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés como consecuencia del trabajo cotidiano, desarrollado por profesionales dedicados al servicio y la ayuda, que no logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo" (Feudenberg, 1974).

Favorecer o acompañar a las familias para que puedan asimilar cognitivamente y emocionalmente la experiencia transitada, atribuyéndole un significado y un propósito, no sólo constituye una ayuda eficaz para estas, sino que contribuirá activamente a la resignificación de nuestra propia experiencia profesional. Cuando nuestras expectativas de curar no pueden ser satisfechas, la frustración que esto genera, debe tramitarse de alguna manera. Este tipo de actitudes, permeables, flexibles, abiertas al aprendizaje, pueden ser nuestro motor en tiempos de agotamiento emocional. Es importante que aún frente al aparente fracaso que la muerte representa, podamos aún encontrar un propósito a nuestras intervenciones.

Cuidado perinatal: concepto y alcance

Afirma Kiman (2017)⁶, que los principios del CP son aplicables en la UCIN, donde pueden ser integrados a los planes de cuidado del paciente y la familia sea que se esté proveyendo un tratamiento curativo, prolongando la vida o brindándose exclusivamente confort hasta que ocurra la muerte esperada (Carter, 2004).

El CP perinatal ha sido definido en los términos que siguen:

'El CP para fetos, neonatos o niños con condiciones que limitan la vida es una aproximación activa y total al cuidado desde el diagnóstico, a través de la vida del niño, en el momento de la muerte y más allá de este momento. Abarca los elementos físicos, emocionales, sociales y espirituales y se enfoca en mejorar la calidad de vida del neonato o niño y sostener a la familia. Incluye el manejo de los síntomas disconfortantes, y el cuidado en la muerte y duelo.' (Together for Short Lives Asociación, UK, 2009).

Siempre que exista diagnóstico prenatal, el CP podrá implementarse en esta instancia en la cual se ofrecerán alternativas, cuyo objetivo será planear o evaluar las decisiones futuras, lo que incluye, siguiendo a Kiman, cómo y dónde se producirá el nacimiento, quien deberá estar presente, notificar al equipo de obstetricia y neonatología, delinear estrategias individualizadas de reanimación cardio-pulmonar, anticipar la posibilidad de administrar medicación bucal (absorción sub-lingual) en caso de que no

sea posible o sea muy traumático obtener una vía endovenosa central o periférica, decidir que intervenciones diagnósticas se realizaran y proveer el soporte espiritual y cultural a la familia.

Abordaje paliativo en neonatología: ¿para quienes?

Si nos atenemos al CP perinatal, los criterios de ingreso bien sea a un Programa de CP o al cambio de estrategia hacia un cuidado paliativo, salvo para algunas condiciones muy especiales, son muy inespecíficos, dado que en gran parte de las condiciones nombradas la incertidumbre pronóstica suele dominar el escenario habitual. Esto tipos de bebés serán los que más desafíos éticos presentaran a la hora de la toma de decisiones.

Las categorías de neonatos pasibles de este abordaje han sido descriptas por algunos autores⁷, entre ellas:

Recién nacidos prematuros: en el límite de viabilidad por el extremo bajo peso o la edad gestacional. Si bien dicho límite varía en los diferentes países, lo ético en estos casos es anticipar las posibles consecuencias de iniciar un abordaje muy agresivo sin evaluar las potenciales secuelas y el sufrimiento al que se expone al neonato y su familia.

Aquí el grado de incertidumbre es alto, por lo tanto un enorme desafío ético para los profesionales del equipo de salud y los padres, que deberán consensuar las decisiones a tomar desde el momento en que se produce el nacimiento del bebé. Como ya se anticipó, las tasas de supervivencia de los prematuros extremos o de extremo bajo peso al nacer, han ido en aumento, sin que esto se acompañe de una reducción en la morbilidad. Cada país, y en nuestra realidad, cada centro, debería iniciar y sostener sus tratamientos e intervenciones considerando, por supuesto, la decisión de los padres que tienen el derecho de conocer las posibles secuelas y consecuencias para anticipar la potencial calidad de vida futura de ese neonato. La decisión debería apuntar siempre a asegurar la mejor calidad de vida, sea cual fuera su duración. También deberá considerarse la disponibilidad de recursos para el cuidado de ese bebé, una vez obtenida el alta. Las tasas de morbilidad pueden diferir bastante de un centro a otro, basado en la disponibilidad de recursos humanos y materiales que impactaran en la calidad del cuidado. De manera que este es también un dato muy importante

que deberá sumarse al proceso de toma de decisiones.

Es importante poner de relieve en este momento, el posible lazo vincular que se haya establecido entre la gestante y su familia por un lado y el equipo de salud en su conjunto (obstetricia, neonatología, diferentes especialidades), considerando y respetando siempre la idiosincrasia, creencias y valores de manera que la toma de decisiones pueda basarse en información clara, respetuosa, veraz y ética.

- ✓ Fetos y recién nacidos con anomalías congénitas complejas incompatibles con una vida prolongada: Anomalías genéticas como trisomía 13, 15 o 18. Triploidias, Dwarfismo Tanatofórico, formas letales de Osteogénesis Imperfecta, Errores Congénitos del metabolismo sin tratamiento curativo.
- ✓ Enfermedades renales: Agenesia Renal Bilateral, algunos casos de Enfermedad Poliquística Renal.
- ✓ Enfermedades del sistema nervioso central: Anencefalia, Acrania, Holoprosencefalia, casos complejos o muy severos de Mielomeningocele o Enfalocelo, Hidranencefalia, enfermedades neurodegenerativas (ej. Atrofia muscular espinal).
- ✓ Cardiopatías congénitas: Acardia, cardiopatías inoperables, algunos casos de Corazón Izquierdo Hipoplásico, Pentalogía de Cantrell (Ectopia Cordis).
- ✓ Anomalías estructurales: algunos casos de Onfalocelo Gigante, algunos casos de Hernia Diafragmática Congénita severa con Hipoplasia pulmonar, gemelos siameses inoperables.
- ✓ Recién nacidos que no responden o que empeoran a pesar de emplear los tratamientos de intensivos adecuados:
- ✓ Ausencia de respuesta a la reanimación cardiopulmonar en el contexto de diferentes patologías
- ✓ Casos severos de lesión cerebral perinatal, así como hemorragias o leucomalacias extensas.
- ✓ Encefalopatía Hipóxico Isquémica grave.
- ✓ Enterocolitis Necrotizantes o vólvulo intestinal sin viabilidad intestinal o con un intestino corto que haga inviable la ali-

- mentación enteral y el crecimiento.
- ✓ Recién nacidos con imposibilidad para retirar ECMO.

Como afirmamos antes, debemos subrayar siempre la necesidad de enfatizar en un análisis reflexivo: la incertidumbre ética suele ser la regla, más que la excepción, en el marco del cuidado de los neonatos gravemente enfermos o extremadamente prematuros.

Como ya hemos señalado: *“Un buen primer paso radica en reconocer que muchos de los cursos de acción que se proponen tienen resultados inciertos. Es decir, si bien hay datos estadísticos que correlacionan el resultado en mortalidad y morbilidad con la edad gestacional y el peso al nacer, ningún profesional puede garantizar en qué parte del gráfico estadístico quedará colocado ese neonato”* (Balanesi, 2018) 8.

Frente a este contexto, el presente trabajo, invita a una reflexión metacognitiva al interior de los equipos ‘intensivistas’, ya que antes de plantearnos la posibilidad de implementar un abordaje paliativo en el contexto perinatal, deberíamos empezar por revisar muy críticamente ciertos procesos de trabajo instalados. Es importante poder reconocer un mecanismo conforme el cual, muchas de las decisiones trascendentes que se van tomando durante esta etapa, suelen implementarse ‘algorítmicamente’, sin consenso, conforme la respuesta que se espera obtener a determinada intervención, en un abordaje fragmentado en los compartimientos estancos compuestos por las diferentes especialidades cuyo foco se coloca, casi exclusivamente, en el órgano o sistema, objeto de cada disciplina.

El centro del análisis se desplaza desde el niño gravemente enfermo-su familia y el contexto-, hacia el conocimiento hegemónico acerca del órgano enfermo que cada disciplina domina, llevando al equipo a una especie de competencia por el más poderoso de los conocimientos intervinientes. A veces la hegemonía se disputa entre los criterios diversos de profesionales de una misma especialidad, incluso de un mismo servicio. El resultado siempre es el mismo: conceptos tales como calidad de vida, intervenciones no fútiles, alivio del dolor, control de síntomas, contención a la familia, espiritualidad, y calidad de vida, quedan totalmente desdibujados. Se pierden. Se diluyen. En general, cuando quieren

retomarse, el dilema ético ya está instalado en todo su esplendor.

Muy frecuentes suelen ser este tipo de situaciones en neonatos prematuros extremos que no responden de manera convencional a los tratamientos que suelen implementarse conforme la evidencia científica disponible (cuidados para la termorregulación, oxigenoterapia, administración de surfactante, nutrición parenteral y suplementos orales de leche materna, prevención y tratamiento de las infecciones, etc.). Los ‘fracasos’ de estas terapéuticas, las complicaciones añadidas, se van sucediendo una tras otra en una sucesión de eventos en los cuales no se habilitan espacios para la reflexión y deliberación. La instalación de ‘procesos deliberativos’⁹ (Arnaez, 2017) para la toma de decisiones consensuadas, acordes a la realidad de cada neonato, es un enorme desafío pendiente.

Comunicación: breves aproximaciones

Debemos ser muy responsables a la hora de comunicar y también saber que podemos entrenar esta habilidad. Los atributos comunicacionales saludables van a propiciar la tramitación del duelo de manera eficaz (o todo lo posiblemente eficaz ante la muerte de un hijo), previniendo que lo traumático no devenga en cuadros melancólicos.

Las vías regias recomendadas, se tejen con el uso de palabras claras, sencillas y pasibles de ser re-preguntadas, mirando a los ojos con un tono de voz que transfiera empatía, con una disposición no verbal como una mano en el hombro de la paciente, el contacto visual –que es el más genuino de los lenguajes- ejercitando el silencio y las pausas (tan poco respetadas en nuestras prácticas siempre apuradas, parafraseando a Spinelli (2010), al ritmo de lo ‘urgente’ desplazando ‘lo importante’.

El silencio otorga espacio y nos interpela a la empatía.

El mensaje deberá ser claro y eficaz, de manera autorizar a los padres a la toma de decisiones con conocimiento de causa. No podremos aliviar el dolor ni quitárselos, pero podemos compartirlo y que sientan que no están solos. Claridad, eficacia y tiempo para procesar la información, serán los integrantes de la mejor fórmula comunicacional para el equipo de salud.

Nuestro psiquismo tiene “mecanismos de de-

fensa” que se ponen en marcha ante diferentes cuestiones vitales, son muchos y muy variados y se manifestaran conforme la vivencia psíquica de cada cual y sus experiencias previas.

Si hay un mecanismo, del cual seremos testigos, será la Negación, la cual hay que respetar. No se trata de barrer con el honor a la verdad, porque está cumpliendo una valiosa función en su economía psíquica y se manifestará cuando veamos reacciones físicas, emocionales, conductuales y espirituales.

Aquí debemos ceder a la hegemonía de “interpretar” y propiciar o acompañar la descarga emocional en todo el tiempo de despliegue que todos los implicados requieran.

Clínica del duelo

Dos temas atraviesan fuertes tabúes en nuestra cultura occidental: la sexualidad y la muerte, que suelen desplegarse invisibilizadas cuando no hay palabras que la nominen.

La influencia del Positivismo en el campo de la salud y su correlato, el “Modelo Médico Hegemónico”, da cuenta, entre otras características, que sólo lo tangible (dimensión biológica) es abordable y que “ese” sujeto, carece de historia, contexto, determinaciones y subjetividad, ya que, especialmente esta última, no es medible, pesable ni pasible de análisis cuantificables. Todo acto médico esta interferido por una serie de elementos biopolíticos, institucionales, subjetivos que modifican e inciden en las características de su práctica.

En contextos perinatales y neonatológicos, somos testigos de dos fuerzas estudiadas, Eros (vida) y Tánatos (muerte), en momentos y contextos donde esa conjunción nos interpela, atraviesa y donde “se pasean” una multiplicidad de cuestiones y corporalidades –también las nuestras-.

Todo bebé tiene una representación psíquica previa a su nacimiento, donde las fantasías y materialización de su presencia, le van otorgando un lugar en el linaje familiar y dando lugar a nuevas identidades a su núcleo, a saber: madre, padre, tíos, hermanos. A esto lo denominamos “anidación psicobiológica” que presupone una adaptación afectiva e instrumental ante el advenimiento de un hijo (Jofré y Enríquez, 2002) 10.

Este proceso de ‘anidación’ no tiene a veces el

final esperado. Las muertes en las UCIN nos interpelan con un devenir personal ligado no solo a nuestro trabajo terapéutico personal con el tema. Aquí se abre un abanico de depositarios de nuestro hacer, que son los contextos familiares ante la temática del duelo.

Como se ha dicho recientemente, *‘cuando los padres se enteran que su hijo, nacido o por nacer, tiene una condición que amenaza, altera o limita su vida, la noticia suele ser devastadora. Su mundo ha sido destrozado a la par de sus expectativas del hijo ‘perfecto’ que se les niega. Los padres se ven forzados a adaptarse rápidamente (...) lo que puede resultar en sentimientos de depresión, y si el niño muere, en un proceso de duelo. Si el niño sobrevive, con o sin secuelas que alteren su vida, las habilidades de los padres para conectar y ‘nutrir’ a ese niño, pueden haber quedado comprometidas’* (Milstein, 2005) 11.

El duelo, duele. El duelo tiene tantas representaciones como los duelantes y podemos desde este espacio, acercar dispositivos o aportes disciplinares del campo psi.

Así, podemos adscribir a que el duelo es el estado psicológico consecuente a la pérdida de un objeto significativo que formaba parte integrante de la existencia. Del duelo, que siempre entraña una identificación con el objeto perdido, se sale mediante un proceso de elaboración psíquica, o “trabajo del duelo” como refiere S. Freud.

El trabajo del duelo (Madinabeitia, 2011) 12, requiere ir quitando de a poco, la energía psíquica puesta en quien, en este caso, ha muerto, y para ello, la humanidad siempre ha utilizado este tiempo en ceremonias y prácticas rituales. Una interrupción en el trabajo del duelo lleva a la melancolía, que surge cuando el sujeto siente el objeto perdido como una parte ineliminable de sí, del cual no se puede separar más que separándose de sí mismo. En este caso el dolor del duelo, de normal, se vuelve patológico.

Cuando muere un bebé, nos encontramos frente a un tipo particular de duelo, que ha sido denominado como “duelo desautorizado” o “duelo anticipado”. Hay toda una cultura que niega fuertemente duelar un bebe en gestación o recién nacido y ello sabemos que impactará y resignificará aquellos viejos duelos no tramitados o no elaborados por la familia y también, cómo no, los duelos/miedos, que puedan estar

atravesando o hayan atravesado los profesionales que toman contacto con esta situación.

Nuestra responsabilidad como equipo de salud para favorecer la elaboración de duelos no patológicos, es muy grande. Cada palabra, cada silencio, cada acción y cada omisión, cobran en este contexto una dimensión inimaginable.

Según se ha sugerido, los equipos de profesionales podemos asumir una “función materna” con los padres - quienes vivencian la disrupción de un proyecto vital- con conductas de contención, acompañamiento e intentando potenciar los recursos de ellos. Y permitirnos una postura abierta y flexible, de manera de estar permeables a nuevos aprendizajes con cada experiencia compartida: resignificando creencias y probablemente, a nosotros mismos.

Cabe aquí recordar que toda la familia estará afectada por la muerte del bebé. Tal como se ha dicho, y más allá de estas aproximaciones teóricas, el duelo “es un concepto individual: algunos ‘sanar’, otros no quieren sanar nunca, otros querrán continuar una relación con el bebé tras su fallecimiento, otros verán la muerte como un final irreversible. Todas las formas de soporte deberían estar disponibles durante el ‘viaje’ de cada familia” 13.

Los padres y otras personas significativas de las familias deben ser alentadas a continuar su rol en el cuidado del bebé en esta etapa. Todo el núcleo familiar debería poder acceder a la posibilidad de expresarse. Muy importante es en esta instancia, la atención a los hermanos. Los hermanos han sido descriptos como los ‘dolientes olvidados’ y puede que no hayan tenido la posibilidad de expresar sus necesidades directamente. “Ellos están afectados no solo por la muerte de sus hermanos sino por el impacto que la pérdida de un niño genera en las relaciones familiares en sí mismas. Los hermanos deben ser incluidos y no protegidos del duelo de la familia, de esta manera ellos no sentirán que también tienen que esconder sus emociones y se sentirán habilitados para poder expresarse” 14.

La muerte de un hijo es una herida narcisista y esto también es vivenciado ante el nacimiento de un niño con discapacidad o la asunción de las morbilidades asociadas a la prematuridad. Se debe favorecer que los padres puedan duelar la pérdida del ideal del hijo soñado.

Un hijo, -todos los hijos-, reaseguran el linaje

y se articula con lógicas fantasías de perpetuación y eternidad y en el caso que nos convoca, la muerte viene a irrumpir los ideales paternos. Ante la devastadora vivencia de la ecuación “hijo-perdida-muerte-”, hay varias cuestiones a tener en cuenta.

En principio y desde los equipos de salud, debemos evitar la medicalización ante la expresión de las emociones. El riesgo que conllevaría dicha postura sería dar lugar a “un no suceso”, viabilizando un concepto acuñado en la literatura, que lo nomina “duelo olvidado” (Cavodebilla, 2007) 15, son sus manifestaciones físicas, emocionales, conductuales, psicológicas y espirituales.

Como nuestra sociedad niega –simbólicamente hablando- las muertes peri y neonatales, lo que se logra es una represión emocional, llegando a ver en muchos casos, que la mujer se culpabiliza y siente que ha sido traicionada por su propio cuerpo.

Disrumpir el trabajo de duelo, evitar que sus manifestaciones se expresen en quien lo está atravesando, no es aconsejable. Interviniendo desde ese lugar, solo estamos dilatando un trabajo psíquico que requiere la presencia de llanto, enojo, angustia entre alguna de sus manifestaciones, como vía regia a descomprimir la energía psíquica y por ende llevar a cabo duelos más sanos.

En muchos casos, lo no validado socialmente, se vive culposamente y, como decíamos al principio, hay tantas formas de duelar, como sujetos duelantes. Por ello, el equipo de salud debe contar con las herramientas básicas imprescindibles, atravesar y aprender de cada experiencia, y teniendo siempre como meta poder propiciar espacios intersubjetivos de empatía y comprensión, dos cualidades comunicacionales imprescindibles de sostén. Esos atributos, son más valiosos que una serie de palabras dichas sin tomar en cuenta cómo quedarán inscriptas en la memoria de los padres.

Cuando nos referimos a los “padres”, incluimos a ambos, en su rol materno y rol paterno, –si lo hubiere-. En muchas experiencias, la figura que ejerza el rol paterno es dejada de lado, sin tomar en cuenta que, será quien normalmente asumirá la responsabilidad de sostener a su pareja. ¿Podrá? ¿Cómo legitimar ese deseo vincular si desde los espacios de salud no se le otorga ese lugar?

Las más recientes perspectivas en materia de

duelo, reconocen que los padres desean continuar sosteniendo una relación con sus bebés, más que ‘dejarlos ir’ (Klass et al, 1996)) Debe asumirse que el duelo por la pérdida de un hijo amado puede nunca terminar o resolverse. *“Sanar luego de la muerte de un hijo no significa estar totalmente libre de dolor. Sanar significa integrar y aprender cómo vivir con la pérdida. Significa tener la capacidad de amar a otros y reinventar una vida nuevamente. La sanación ocurre cuando los padres deciden que no sólo a través del dolor pueden seguir expresando el amor que sienten por ese hijo”*¹⁶

Por ello, desde el equipo de trabajo, es dable cuestionar y repensar esa mirada/intervención que suele observarse con una cierta frecuencia: paternalista hacia la madre, negligente hacia el padre y evitadoras ante el bebe.

Conclusiones

Los CP neonatales no son un privilegio sino un derecho al que toda familia con bebés gravemente enfermos debería poder acceder desde el diagnóstico inicial, a lo largo de toda la enfermedad –independientemente de su duración–, que como vimos, puede ser muy variable–, durante la muerte y a lo largo del duelo.

Lograr que esto deje de ser una utopía requiere en primer lugar, un proceso personal de introspección mediante el cual trabajemos en nuestra interioridad el significado y propósito que le atribuiremos a estas experiencias, que seguramente tendremos que atravesar en algún momento de nuestro transcurrir profesional.

En segundo lugar, repensar ciertas prácticas instaladas en los servicios de salud que se ocupan del cuidado neonatal, desde la consulta prenatal y hasta la internación en servicios de cuidados intensivos o complejos. Introducir al interior de nuestras prácticas procesos deliberativos y de toma de decisiones compartidas, es tan desafiante como urgente. Si bien desde el ámbito académico hemos zanjado algunas cuestiones y trascendido el modelo reduccionista y bio-patológico, éste sigue vigente en muchos aspectos de nuestra praxis cotidiana. Las actitudes paternalistas, la aplicación de terapias curativas sin discriminar respuestas individualizadas y necesidades de cada bebé y sin medir el impacto en la calidad de vida futura desenmas-

caran la resistencia a ceder el territorio de poder hegemónico que por mucho tiempo concedió el saber.

Cuando lo innombrable se subjetiva, cuando la censura social que vela al tabú se levanta para imponerse en una realidad que ahora tiene un rostro y una historia, es probable que no nos hayan enseñado, o no sepamos qué hacer y cómo actuar. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado.

Adherimos a la implementación de programas de CP integrales, que sienten sus bases en paradigmas humanistas, destacando, como se esbozó la importancia de ‘estar con’. Si para curar es necesario ‘hacer con’, para sanar se requiere ‘estar con’.

Cultivar una actitud de ‘estar con’ sumada a la de ‘hacer con’ ayuda a los cuidadores a conectar con los pacientes y sus familias. Como se ha afirmado *“el simple hecho de interesarse por lo que el otro siente acerca de lo que está ocurriendo en su vida, puede contribuir a favorecer el proceso de sanación, trascendiendo la curación. Prestar atención a las necesidades cognitivas, emocionales y espirituales, superando la atención exclusiva a las necesidades físicas...”* (Milstein, 2005) ¹⁷. Colaborar en poder encontrar un propósito y significado en este viaje final de cada neonato es nuestro gran desafío.

Quizás se trate sólo de asumir que este golpe a nuestro ego solo nos está queriendo recordar que no se trata de hacer o actuar. O sí, pero poniendo en juego otras acciones, esas que se construyen creativamente, sin fórmulas mágicas, a la par de sus protagonistas.

Que en este territorio sagrado, de disputa entre la vida y la muerte, de encontrar sentido al ‘sin sentido’, todos nuestros conocimientos y el poder que esto nos otorgó cuando creíamos tener todas las respuestas, ya no sirven.

Ser y estar.
Tan simple.
Y tan complejo.

Referencias

1. Kiman R et al. Perinatal palliative care: a developing specialty. *International Journal of Palliative Nursing* 2014, Vol 20, No 3: 143-148.
2. Ciruzzi M et al. Los Cuidados Paliativos como Derechos Humanos. *El rol del sistema de salud público y de la familia en pacientes con patologías crónicas amenazantes de la vida. Primera Parte.* 2019. MJ-

DOC-15013-AR. MJD15013

3. Piccinini V. *El arte de acompañar: herramientas y prácticas para el acompañamiento personal y espiritual en cuidados paliativos*. Hypatia Ediciones, Buenos Aires.
4. Luna F. Vulnerabilidad: un concepto muy útil, abandonando los "corsés teóricos" Respuesta a "vulnerabilidad: ¿un principio fútil o útil en la ética de la asistencia sanitaria?" *Revista Redbioética/UNESCO*, 2(4), 2011 - ISSN 2077-9445.
5. Milstein JA. *Paradigm of Integrative Care: Healing with Curing Throughout Life, "Being with" and "Doing to"* *Journal of Perinatology* 2005 25:563-568
6. Kiman, R Op.Cit
7. Hospital Sant Joan de Deu. Convocatoria 2017 Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cataluña, España.
8. Balanesi M. Comentario de artículo. Aspectos éticos en el cuidado intensivo neonatal. *Revista de enfermería neonatal*, Diciembre 2018, 28:39-43
9. Arnaez J et al. La bioética al final de la vida en neonatología: cuestiones no resueltas. *An Pediatr (Barc)*. 2017;87(6):356.e1-356.e12.
10. Jofré R et al. Nivel de estrés de las Madres con Recién nacidos Hospitalizados en la UCIN Hospital Guillermo Grant. 2002. *Ciencia y Enfermería*, 8, 31-36
11. Milstein, J. Op Cit.
12. Madinabeitia A. Duelo perinatal: un secreto dentro de un misterio. 2011. *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.*, 2011; 31 (109), 53-70.
13. Mac-Namara C et al. ACT (Association for Children's Palliative Care). A Neonatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs. 2009. Brunswick Court, Brunswick Square, Bristol
14. McNamara C C et al. Op.cit.
15. Cabodevilla L. Las pérdidas y sus duelos. *Anales Sis San Navarra [online]*. 2007, vol.30, suppl.3 [citado 2020-04-02], pp.163-176.
16. McNamara C C et al. Op.cit.
17. Milstein, J. Op Cit

Bibliografía

-
- Fernández R et al. Supervivencia y morbilidad en recién nacidos de muy bajo peso al nacer en una Red Neonatal sudamericana.
- Freud S. (1917/1915/) Duelo y melancolía. En: *Obras completas*. Tomo VI. Biblioteca nueva, Madrid. 1975. Pp237-55
- Gamo E. et al. (2000). Problemática clínica del duelo en la asistencia en salud mental. *Psiquiatría Pública*, 12, 3, 209-218
- Kubler-Ross E. *Los niños y la muerte*. Barcelona: Luciérnaga; 1992, p. 20-28.
- Perrota G. *El rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario de salud. Cuerpo y Subjetividad*. S/d: AASM
- Spinelli H. *Las dimensiones del campo de salud en la Argentina*. 2010. *Salud Colectiva*, Buenos Aires, 6(3):275-293
- Tonon Graciela. *Calidad de vida y desgaste profesional: una mirada del Síndrome de Burnout*. 2003. 1ra ed. Buenos Aires
- UNICEF-SAP. *Salud Materno Infante Juvenil en Cifras 2019. Estadísticas vitales. Información básica Argentina - Año 2018*. Ministerio de Salud. Secretaría de Acceso a la Salud. Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica Dirección de Estadística e Información en Salud

*Lic. Marianela Balanesi

Abogada. Lic. Esp. en Enfermería Neonatal. Miembro del Comité de Bioética del HIGA-HIEMI Mar del Plata, Docente de la Cátedra Salud del Niño, Niña y Adolescente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

**Lic. Claudia Mónica García

Lic. En Psicología. Titular de la Cátedra Salud Pública y Salud Mental. UAA-UNMdP. Docente, Conferencista e Investigadora. Trabajo en los Hospitales de General Conessa, Gral. Madariaga, HIGA e INAREPS.

CUIDADOS PALIATIVOS PERINATALES: ¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO?: ALGUNAS APROXIMACIONES A SU IMPLEMENTACIÓN. PARTE II.



DRA. RUT KIMAN*

LIC. MARIANELA BALANESI**

Sumario

Se aporta evidencia basada en la experiencia y evidencia local y extranjera, para determinar cuáles son las condiciones que requieren cuidados paliativos en el inicio de la vida, describir el proceso de atención en situaciones de amenaza a la vida perinatal y colaborar en el reconocimiento del apoyo y herramientas que el equipo de salud necesita para brindar cuidados paliativos en el contexto perinatal. Se destaca la íntima conexión y afinidad entre la atención centrada en la familia y el CP perinatal. Las intervenciones de los equipos de CP apuntan a mejorar la calidad de vida de los neonatos a la par que empoderan a las familias y los profesionales en la toma de decisiones consensuadas, lo que podría favorecer la adecuación del esfuerzo terapéutico cuando sea necesario y prevenir duelos complicados.

Introducción

En el artículo anterior se abordaron algunas generalidades relacionadas con el cuidado paliativo perinatal, centrando el eje en el enfoque de derechos, definiendo los conceptos y alcance del mismo, algunas dificultades encontradas en nuestra praxis cotidiana que podrían conspirar contra su efectiva implementación en la dinámica de los procesos de trabajo tal y como se encuentran configurados hoy día sobre todo en

las áreas críticas, la importancia de trabajar la comunicación como herramienta imprescindible para una atención integral que aborde la 'experiencia humana de enfermedad' y de favorecer el desarrollo de duelos 'no patológicos' para las familias que atraviesan la dura experiencia de la pérdida de un bebé.

A través del presente artículo se aportará evidencia basada en la experiencia en el ámbito local y extranjero y los más recientes estudios, para determinar: a) las condiciones que requieren cuidados paliativos en el inicio de la vida, b) describir el proceso de atención en situaciones de amenaza a la vida perinatal y c) colaborar en el reconocimiento del apoyo que el equipo de salud necesita para brindar cuidados paliativos.

Antecedentes

En los últimos 50 años, hubo cambios notables en el cuidado del recién nacido. Varias áreas clave se han ido desarrollando y mejorando, proporcionando así la base para el cuidado de todos los recién nacidos: termorregulación, nutrición, normas de crecimiento, apoyo para la función respiratoria, corticosteroides prenatales, uso de surfactante exógeno, monitores de saturación de oxígeno, óxido nítrico inhalado, oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), manejo de hiperbilirrubinemia severa, manejo de la infección neonatal, estrategias de

nutrición, la regionalización y la incorporación de los padres en el cuidado de sus bebés (1).

El desarrollo de la tecnología médica ha cambiado cuándo, dónde y cómo morimos. La toma de decisiones al final de la vida para los recién nacidos con pronóstico adverso sigue siendo un desafío. Tal como se mencionó, este enorme desafío suele instalarse al interior de servicios poco habituados y a menudo, algo resistentes a compartir el territorio de toma de decisiones con los padres, aspecto clave si queremos empezar a pensar en la implementación real de cuidados paliativos en el contexto perinatal.

Los primeros problemas relacionados con esta pregunta aparecieron en los años 80 (2-3). En todo el mundo, la mayoría de las muertes neonatales ocurren en entornos hospitalarios, por lo general, pocos padres pueden llevar a sus bebés a morir en casa con el apoyo adecuado o en un hospicio para niños. Los recién nacidos y los bebés tienen la tasa de mortalidad más alta en la población pediátrica. Sin embargo, hay muy pocos datos disponibles sobre el cuidado al final de la vida y si los cuidados paliativos podrían tener algún impacto para ayudar a los bebés y sus familias a lo largo del viaje. El cuidado paliativo para los recién nacidos, es un área aún en desarrollo (4).

Por otro lado los avances científico-tecnológicos en Obstetricia permiten una detección cada vez más precoz de patologías y malformaciones complejas. ¿Qué sucede hoy en día cuando una mujer está embarazada y su hijo es diagnosticado antes del nacimiento con una condición que limita o que amenaza la vida? ¿Qué necesitan los padres para tomar su decisión? Hay un elemento clave, un valor muy cotizado pero escaso en el habitual –y siempre apurado– escenario de atención de la salud: el tiempo. Necesitan tiempo para empezar a entender la condición del niño, necesitan tiempo para examinar las alternativas de terminación o continuación del embarazo, -riesgos y beneficios de cada alternativa-, necesitan se respeten sus valores o creencias (5).

Las decisiones sobre la planificación del cuidado perinatal del final de la vida deben basarse en la mejor información posible sobre el diagnóstico y pronóstico de la afección subyacente. Estos pueden agruparse en tres categorías (6):

- diagnóstico y pronóstico certero
- diagnóstico certero y pronóstico incierto y,

- diagnóstico incierto y pronóstico certero.

Los médicos tienen el deber de reconocer su papel único en el cuidado de los pacientes: «la madre y el feto». Es esencial que los médicos brinden información con respecto al riesgo, beneficio y carga tanto para la madre y el feto de forma individual. Sólo el 39% de los países del mundo permite legalmente la interrupción del embarazo cuando se diagnostica una anomalía fetal grave.

Tal como se abordó en el capítulo anterior, la información debe ser clara, veraz, sensible, culturalmente competente, respetando la dignidad e integridad del neonato y su familia y siempre asegurando que sea comprendida. La responsabilidad de que la familia efectivamente comprenda –operación mental que implica integrar la información escuchada-, incumbe al equipo de salud: debe asumirse que esta será la base sobre la cual se iniciará el proceso de toma de decisiones en una permanente búsqueda de manejar razonablemente la incertidumbre y conseguir tomar una decisión prudente.

Otro problema en general no visualizado, son las muertes intrauterinas (embarazos de más de 22 semanas) que se elevan a 2.6 millones en el mundo. La mitad de esas muertes (1,3 millón) ocurre durante el trabajo de parto y el nacimiento, 98 % en países de bajos y medianos ingresos, 1 de cada 40 fetos morirá antes de nacer y 25 de cada 1.000 recién nacidos antes de los 30 primeros días de vida. La mayoría de ellas se podrían prevenir, 4,2 millones de madres viven luego con síntomas de depresión (7).

En España, según datos de UMAMANITAS, un 30% de las mujeres que dieron a luz a un bebé fallecido no estuvieron acompañadas por sus parejas u otra apersona de su elección en muchas ocasiones por prohibición expresa del personal sanitario. Muchas mujeres y sus parejas no tuvieron la oportunidad de conocer a su hijo/a después del parto por falta de información y apoyo. En nuestra cultura ‘punitiva’ del error esta acción u omisión podría ser calificada como imprudencia, negligencia o impericia, incluso dolo. No obstante, estos hechos, pasan inadvertidos, excepto para quienes los padecen en silencio. El equipo de salud parece no advertir el valor que sus acciones u omisiones pueden adquirir en esta instancia en la cual una familia escribe en su biografía, probablemente el más triste de sus capítulos.

A la mitad de las mujeres se le administraron sedantes durante su estancia en el hospital a pesar de que está contraindicado por efectos negativos sobre el duelo (8). La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) señala que en 2016 se produjeron en Argentina 6.086 defunciones fetales y una tasa de mortalidad perinatal del 11,4% (en 2015 fueron 6.164 defunciones y una tasa de mortalidad perinatal del 11,3%).

Suele ser tristemente frecuente, encontrar en los pases de sala de los alojamientos conjuntos de algunas instituciones, mujeres duelando la pérdida de sus bebés intra-útero transitando el puerperio inmediato al lado, en la misma habitación y en la cama contigua a la que se ubican madres que acaban de dar a luz saludables bebés. Como profesionales, no podemos perder la sensibilidad frente a este tipo de situaciones. La falta de camas, o de espacios adecuados debería suplirse con creatividad y sensibilidad, además de anticipar desde la gestión alternativas compasivas que impidan que esto se siga repitiendo.

Incorporar a los Cuidados Paliativos (CP) en este contexto tiene como finalidad minimizar situaciones de sufrimiento tanto en el feto o recién nacido, como en las mamás/ familias y también en los equipos primarios tratantes. Como sugerimos en el artículo anterior, toda intervención cuyo objetivo central sea humanizar la atención, va a generar una retroalimentación positiva hacia el equipo de salud, aún en situaciones extremas o muy tristes: este tipo de intervenciones nos permite resignificar nuestra tarea, ayudándonos a recuperar su propósito y sentido, y devolviéndonos quizás, la motivación que alguna vez pudo impulsarnos a elegirla.

La noción misma de los cuidados paliativos ha evolucionado para abarcar los cuidados paliativos al área perinatal, que incluye, entre otras cosas, la idea de atención integral y atención temprana e integradora iniciada prenatalmente (9).

La atención inicial proporcionada para los aspectos más físicos, como el alivio del dolor y la comodidad (en un contexto multisensorial) se complementa de inmediato con la importancia del vínculo materno y otros aspectos emocionales. La importancia de la participación familiar en la UCIN, que encontró expresión en el concepto de “atención centrada en la familia” en los años sesenta y setenta, también podría tener cierta influencia en los CP neonatales.

Unas de las más recientes expresiones de este

tipo de atención en el contexto perinatal es el ‘Modelo avanzado de cuidado para el desarrollo integral de Altimier y Phillips: siete medidas neuro-protectoras del cuidado para el desarrollo centrado en la familia’ (10), pone en el eje de su enfoque en las experiencias interpersonales del bebé y su familia durante su estadía en la UCIN, y propone la creación de una ‘sociedad de cuidado’ con los padres, en una filosofía que reconoce el rol protagónico de la familia, considerándolos ‘miembros esenciales y socios activos del equipo de cuidado de su bebé (no meros visitantes) con acceso sin restricciones horarias y asumiendo que tienen la mayor influencia sobre la salud y bienestar de su hijo’.

Recientemente, se ha llamado la atención sobre la necesidad de “atención integral”. Usando este término, Milstein destaca la importancia de introducir la curación y la paliación (cuando está indicado) junto con medidas curativas tan pronto como cualquier diagnóstico, especialmente uno crítico, como un paradigma integrador de atención. También señala que debido a que la pérdida se puede experimentar en muchas condiciones, incluso en ausencia de muerte, el duelo se representa como un proceso continuo y a lo largo de una enfermedad (11).

La toma de decisiones compartida (SDM) promueve la asociación y la comunicación entre los equipos tratantes y los pacientes con respecto a la evidencia, las experiencias clínicas y las preferencias del paciente. En pediatría implica asociaciones entre los médicos, los padres y el niño y disminuye los conflictos entre las partes. El desafío es comunicarnos unos con otros con claridad, compasión y colaboración mientras nos esforzamos en mejorar la calidad de vida de estos niños, incluyendo, cuando sea necesario, la trayectoria final de su vida (12).

Una decisión no es un fenómeno unitario; es un proceso que se desarrolla en pasos. Para cada decisión, alguien debe primero reconocer que una elección debe hacerse, identificar las posibles líneas de acción, las ventajas y desventajas de cada alternativa y sopesar la «probabilidad y deseabilidad» de cada resultado. Este trabajo preliminar puede ser realizado por el médico, los padres o los pacientes según su edad o, puede ser compartido por todos. Sin embargo, cuando se comparan las opciones y el riesgo, el médico, como experto, suele la persona «más preparada» para identificar, evaluar y explicar los po-

sibles cursos de acción. La toma de decisiones compartida es más necesaria, quizás, cuando los resultados pueden ser inciertos. Como en neonatología, el nivel de incertidumbre suele ser elevado, pensamos que la introducción de esta práctica como hábito de trabajo, es fuertemente recomendable.

Los principios de los cuidados paliativos se pueden aplicar en la UCIN, donde pueden integrarse al plan de tratamiento de los recién nacidos y al cuidado de la familia, independientemente de si el objetivo del tratamiento es obtener una cura, la prolongación de la vida, o si se trata exclusivamente de cuidados paliativos y de confort hasta que ocurra, en un determinado y variable período de tiempo, la muerte esperada. En estas situaciones, particularmente, cada minuto cuenta. Algunos bebés sólo sobreviven algunas horas fuera del útero: aportar calidad a ese tiempo, es clave. La incubadora o cuna que acoge al bebé muriente, se sitúa físicamente en el contexto de una terapia neonatal, con sus inherentes urgencias y ocupación permanente en salvar las vidas de los neonatos con opciones curativas disponibles, lo que hace que nos preguntemos, si este es el espacio adecuado para alojarlos. Al igual que lo que ocurre con las puérperas de fetos muertos intra-útero, la excusa de la falta de espacios apropiados, no debería dejar de interpelar nuestra sensibilidad y la búsqueda de alternativas.

Retomamos aquí el concepto volcado en el capítulo anterior, que define a los cuidados paliativos para un feto, neonato o recién nacido con una condición que limite la vida implican un enfoque activo y total de la atención, desde el momento del diagnóstico, a lo largo de la vida del bebé, en el momento de la muerte y más allá. Consideran aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales y se centran en la mejora de la calidad de vida para el recién nacido y el apoyo a la familia. Incluyen el manejo de síntomas discomfortantes, la provisión de cuidados de respiro, el cuidado en el momento de la muerte y durante el proceso de duelo (13).

¿Qué bebés son elegibles?

Otra forma más sencilla de describir los bebés elegibles para el cuidado paliativo es la que se propone a continuación. Son elegibles los bebés que nacen demasiado pronto, los que están demasiado enfermos, los que no responden a los esfuerzos de cuidados intensivos, los que están

sufriendo hasta el punto en que las terapias representan una carga o cuyo estado no permitirá ningún tipo de vida significativa: a todos éstos bebés se les ofrecen cuidados paliativos (14).

- Categoría 1. Condiciones potencialmente mortales para las cuales el tratamiento curativo puede ser factible pero puede fallar. Ejemplos: prematuridad extrema, enterocolitis necrotizante grave, cardiopatía congénita.
- Categoría 2. Condiciones en las que la muerte prematura es inevitable. Puede haber largos períodos de tratamiento intensivo dirigidos a prolongar la vida. Ejemplo: anomalía cromosómica, espina bífida grave.
- Categoría 3. Condiciones progresivas sin opciones de tratamiento curativo. El tratamiento puede extenderse comúnmente durante muchos años. Ejemplo: riñones multiquísticos bilaterales graves, displasia esquelética, trastornos neuromusculares graves.
- Categoría 4. Condiciones irreversibles pero no progresivas que causan discapacidad grave, susceptibilidad a complicaciones de salud y probabilidad de muerte prematura. Ejemplo: encefalopatía hipóxica-isquémica grave.

Intervenciones interdisciplinarias para abordar la atención en el área paliativa perinatal:

Algunas condiciones pueden ser diagnosticadas prenatalmente, ya sea por medio de una ecografía y/ o el diagnóstico genético. Cada lugar decidirá la forma más conveniente de ofrecer el servicio, lo importante es la identificación de las pacientes y el seguimiento posterior, sea en el primer nivel de atención o en centros de mayor complejidad donde el espacio de prestación puede no ser siempre UCIN y puede incluir sala de partos, unidad de preparto, unidad de post-parto, un hospital más cercano al domicilio o la casa de la familia (15).

La identificación del entorno adecuado debe ser discutida con la familia junto con los servicios disponibles para realizar el apoyo a la familia. El trabajo en equipo interdisciplinario, tiene como meta el bienestar de pacientes, familias y equipo primario tratante, hacer menos doloroso lo que están viviendo, dar confort y compañía, independientemente del rol profesional que cada uno ocupe en dicho equipo (16). Es menes-

ter de los referentes de cada uno de los servicios participantes coordinar la actuación de los profesionales intervinientes. Se realizan las entrevistas con los distintos profesionales (médico obstetra, neonatólogo, obstétrica, enfermera) junto a la psicóloga del equipo. Esto puede ser una tarea difícil, ya que requiere mejorar la articulación entre todos los servicios y niveles de atención que intervienen en el seguimiento y control del embarazo, nacimiento e internación en la UCIN y gestionar los procesos de trabajo actuales poniendo el foco en la embarazada y su familia.

No obstante, se recomienda muy fuertemente, en todos los casos en que se identifica un embarazo de riesgo ya que se trata de una medida de sencilla implementación y bajo costo. La bibliografía sugiere algunas medidas muy sencillas como la presencia de los médicos o enfermeros de neonatología durante la instancia de atención prenatal o internación materna por cualquier causa que amenace la salud del bebé por nacer, o la posibilidad de que los padres puedan realizar una visita a la unidad de cuidado donde el bebé quedaría internado tras su nacimiento (17).

El proceso de toma de decisiones considera aspectos biológicos, emocionales y sociales y se transmite a la familia. Las familias pueden prepararse para varios escenarios: qué el bebé viva más tiempo de lo esperado, qué el bebé viva menos tiempo de lo esperado, qué el bebé muera en el útero, qué el bebé requiera medidas de reanimación.

A continuación se describen las intervenciones del equipo interdisciplinario de cuidados paliativos perinatal a lo largo del seguimiento (18):

1. Evaluación de la unidad de cuidados: teniendo en cuenta el historial de la diada parental, la percepción de enfermedad, antecedentes familiares de pérdidas anteriores, lugar del embarazo en la configuración familiar, búsqueda de familia extendida.

2. Aclarar la trayectoria de la enfermedad: que comprende aspectos relacionados con información diagnóstica y pronóstica, mantener una escucha activa basada en la narrativa del paciente: debemos comprender y respetar los valores y creencias. Una pregunta que podría ayudar en esta pesquisa es la siguiente: ¿por qué cree que esto le sucedió a su bebé? Habilitar el espacio para el silencio y la escucha es clave en esta etapa y siempre que intentemos comunicarnos con

las familias.

3. Estrategias de afrontamiento: indagar en aspectos tales como: gestión por parte de la familia del afrontamiento de la enfermedad, manejo de la incertidumbre, el duelo por el “niño imaginado”, intentar precisar si pueden expresar una búsqueda de significado (¿por qué me está pasando esto a mí?), indagar en las representaciones maternas y paternas del niño deseado, han pensado un nombre para su bebé?

4. Seguimiento durante el embarazo: son fundamentales las reuniones del equipo interdisciplinario para la toma de decisiones, decidir una atención psicológica específica si fuera necesario, evaluar los factores de riesgo para la prevención del duelo complicado, proveer educación cuando la atención domiciliaria es un posible escenario y generar una eventual solicitud de equipos y suministros para el cuidado en el hogar.

5. Seguimiento durante la hospitalización: realizar un acompañamiento durante el parto, frente a la muerte intrauterina (muerte fetal) o el acompañamiento en UCIN. De ser factible, gestionar espacios adecuados para transcurrir el duelo, en espacios donde no tengan que exponerse a las vivencias de otras familias que celebran nacimientos de bebés sanos, o en espacios especialmente acondicionados en las UCIN, donde puedan mantener cierta privacidad.

6. Toma de decisiones compartida: La naturaleza y complejidad de las decisiones es altamente variable y puede implicar situaciones durante el proceso diagnóstico, sobre la evaluación, las opciones de tratamiento, la atención o la gestión y servicios de apoyo. Por tanto es fundamental la planificación anticipada de los cuidados, la planificación en el final de la vida, la eventual solicitud al Comité de Bioética para participar en casos difíciles de resolver, y la planificación de situaciones inesperadas teniendo siempre un plan paralelo.

7. Acompañamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: consensuar las decisiones sobre qué intervenciones diagnósticas o de tratamiento deben realizarse, proveer apoyo emocional a la familia, asesorar sobre el manejo de la sedación o analgesia, compartir el proceso de toma de decisiones en situaciones de diagnóstico o pronóstico cierto / incierto y acompañar al equipo tratante para evitar la fatiga por compasión o situaciones de estrés moral.

8. Seguimiento posnatal ambulatorio: en caso de poder irse de alta coordinar un buen control de síntomas, acompañar a la familia para su posibilidad de afrontamiento del “niño real”, solicitar equipo y suministros para la atención en el hogar, colaborar en la organización familiar para la atención, y derivación a otros servicios si es necesario.

9. Acompañamiento en el duelo: utilizar y conocer predictores de duelo complicado después de la pérdida prenatal o postnatal, detectar reacciones que corren el riesgo de afectar negativamente el bienestar psicológico y físico de la familia.

10. Cuidado de los que cuidan: El sentido fundamental de los equipos interdisciplinarios es compartir. En estos equipos se comparten los pacientes, se discuten diagnósticos y acciones terapéuticas, así como preocupaciones o sentimientos que genera el hecho de asistir pacientes con situaciones complejas o enfermedades sin opción curativa; se comparten también logros y fracasos, de esta forma, el trabajo en equipo disminuye la tensión particular de cada integrante.

ESCENARIO CLÍNICO: “ALMA”

Nace por cesárea programada el mes de julio, Gesta 7, Parto 2, Cesárea 4 (G7P2C4), GRUPO A RH negativo, Prueba de Coombs Directa negativa. Recién Nacido de Término/Alto Peso para la Edad Gestacional (RNT-APEG). Edad Gestacional: 35 sem. Peso: 4.267 grs. Talla: 50 cm. Perímetro Craneal. 38cm. Apgar 9/10. Su madre presenta una DBT tipo 1, Serologías negativas. FC: 155 x minuto Sat 98% con O2 ambiente. Pasa a UCIN con alimentación por Sonda Orogástrica y atención paliativa. Evaluada por el equipo interdisciplinario de cuidados paliativos perinatales (EICPP).

Se observa la presencia de una malformación en zona occipital defecto de 10 cm íntegro cubierto por membranas, suturas normotensas, paladar íntegro y cuello simétrico. Controles de laboratorio sin alteraciones. Ecografía cerebral: eco-estructura cerebral distorsionada, ventrículos laterales no dilatados, tercer ventrículo no se observa, acueducto de Silvio permeable, cuarto ventrículo no visualizable, disgenesia de cuerpo calloso, circunvalaciones distorsionadas. Malformación cerebral compleja. Ecografía abdominal:

sin particularidades. Interconsulta a Cardiología: 4 cámaras predominio de cavidades derechas, 2 válvulas AV permeables, sin derrame pericárdico, Comunicación Interauricular clínica 3mm, Ductus Arterioso Permeable fisiológico.

Previamente durante los meses anteriores y en el seguimiento prenatal: Fecha Ultima Menstruación 21-11-2017, EG 21.1 semanas, Feto único situación transversa, Movimientos Fetales+, Distancia Biparietal 47 mm = 20.1 semanas; Circunferencia Cefálica 182 mm = 20.05 semanas; Circunferencia Abdominal 195 mm = 24.2 semanas; Largo Fémur 45 mm= 25.2 semanas. Peso Fetal Estimado 653 grs, P >90 - Placenta fúndica anterior Gr: 0-I Líquido amniótico normal.

Scan fetal: polo cefálico presenta solución de continuidad a nivel occipital bajo con defecto de cierre de 15 mm aproximadamente con exteriorización de estructuras encefálicas a predominio occipital, conforma una estructura aproximada de 47 x 45 mm. Imagen compatible con encefalocele occipital. Resto del scan: sin particularidades

Primera entrevista con el EICPP: abril

Motivo de consulta: valorar comprensión diagnóstica y pronóstica.

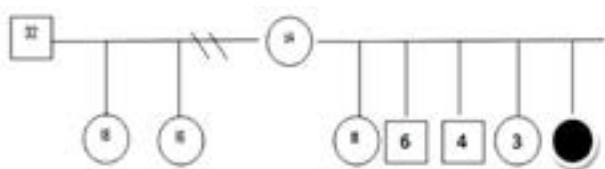
EG: 24 sem FPP: 9 /08 /2018

Blanca nos cuenta que una hermana fallece en un incendio hace 4 años, luego a los pocos meses empeora la demencia y depresión de su padre quien también fallece. En Febrero muere su mama por DBT insulino-dependiente. Presenta ideación suicida posterior a estos eventos. Embarazo no planificado. Refiere dos internaciones por su DBT en Enero y Abril del corriente año (6 y 10 días). Hace aproximadamente 10 años le diagnosticaron DBT insulino-dependiente.

Segunda entrevista con el EICPP: 3 de mayo

Motivo de consulta: Toma de decisiones-Prevención de duelo complejo

Se trabajan pautas para hablar con sus hijos, de distintas edades, respecto del embarazo dado que “no saben que está embarazada”. No quiere contarles por el pronóstico de su bebé. Ella siente los movimientos de su bebé y le habla, le preguntamos y quisiera llamarla “ALMA”, pero “no puedo hablar ni llorar con nadie”. Tenía un vínculo muy cercano con sus padres y su hermana. Se pregunta por qué le pasa esto a ella que siempre estuvo presente para todos.



Tercera entrevista con el EICPP: 8 de Mayo

Motivo de consulta: Interrupción legal del embarazo (ILE)

Paciente internada en la sala de Obstetricia, concurre al consultorio ante la posibilidad de que se tome la decisión de interrumpir el embarazo por parte del equipo interdisciplinario de Medicina Fetal, dada la situación clínica de la misma quien presenta una DBT Tipo I con descompensación metabólica. Manifiesta interés en que se le brinde información de los pasos a seguir ante la posibilidad de dicha interrupción y pensando si su bebe llegase a nacer con vida o no. Refiere querer verla y respetar los rituales de bautismo y despedida como así como también la posibilidad de llevarse el cuerpo de su bebe para darle sepultura. Se la observa claramente angustiada pero tranquila al momento de la consulta.

Cuarta entrevista con el ECPP: 9 de Mayo

Motivo de consulta: Reunión interdisciplinaria con Obstetricia (Medicina Fetal) y posterior informe a los padres

Considerando que los padres no tienen una postura clara con respecto a la ILE, se decide darles más tiempo. Se solicita IC con psiquiatría para valorar cuadro depresivo (ideación suicida). Se solicita turno para realizar RMN con el objeto de establecer mayor certeza diagnóstica y pronóstica. Los padres acuerdan con estas decisiones. Se otorga el alta y se citan para seguimiento ambulatorio.

Quinta entrevista con el ECPP: 31 de Mayo

Motivo de consulta: Se realiza entrevista de seguimiento a la que la paciente acude espontáneamente

Refiere haber estado sintiéndose “descompuesta” y sin ganas de salir de su casa. No quiere cruzarse con gente y que le pregunten por el embarazo. Pudo hablar con sus hijos mayores acerca de la situación del embarazo y el pronóstico. Refiere sentirse más aliviada. También pudo comprar ropa de bebé para traer al hospital. Manifiesta su deseo de que se le puedan colocar los aritos. Piensa que de adelantarse la cesárea, su bebé va a tener menos posibilidades

de sobrevivida.

Sexta entrevista con el ECPP: 19 de Julio

Motivo de Consulta: Manejo de la Incertidumbre y planificación anticipada

Recibimos los siguientes estudios de obstetricia: ECOG.OBST: 19/07/18 (34.2 semanas), Diámetro biparietal: 7.7 cm, (30.4 semanas) Circunferencia craneal 29.6 cm (31.3 semanas), Circunferencia abdominal: 39.4 cm (+40 semanas). OSIMETRÍA FEMORAL: 7.4 cm. (38 semanas). PESO ESTIMADO: >4000 GRS PC: >95 (34 semanas). Placenta Fúndica Anterior. G: II/III. Líquido amniótico: ligeramente aumentado. ENCEFALOCELE POSTERIOR. RMN FETAL: 30/05 29/30 semanas, a nivel occipital bajo: protrusión extra-craneal de contenido meníngeo y parénquima compatible con menigo-encefalocele, saco herniario dl : 46mmxdap:37mmxdt:42mm. No se puede descartar compromiso cervical posterior.

Se trabajan aspectos relacionados con el estudio que trae (resonancia magnética) en el informe del mismo se observa confirmación diagnóstica. Blanca refiere sentirse sola por momentos a pesar de concurrir a la consulta con Máximo, su pareja, dice «necesitaba tomarme tiempo para hacerme a la idea en esta situación que me toca vivir». Pudo hablar con sus hijos sobre la situación del embarazo. Consiguió el teléfono de un sacerdote para avisarle cuando nazca “ALMA” y que pueda venir a bautizarla. Habla sobre la posibilidad de la colocación de aros, pudo comprar unas ropitas y unos pañales para su bebe. Se trabajó sobre la incertidumbre que nos plantea el nacimiento de la bebe. Se plantean escenarios posibles, el acompañamiento a la bebe y nos manifiesta el deseo «que no sufra situaciones innecesarias».

Séptima entrevista con el ECPP: 24 de Julio

Motivo de consulta: Se realiza entrevista de seguimiento

Concurre a la consulta sola, tranquila y nos pide que veamos los resultados de los últimos laboratorios. Al comenzar la charla manifiesta querer saber qué cosas ocurrirán si la bebe no nace con vida: “siempre decimos si ALMA nace viva tal vez esto o lo otro, todo depende y si no, esa es mi pregunta”. Se le explican los trámites en situación de Feto muerto, o bebés que nacen con vida y fallecen a las pocas horas. Refiere ciertos rituales de despedida que desea se respeten, que sea Máximo el que reciba la informa-



ción de la situación de ALMA solamente y quien le transmitirá a ella esas novedades. Solicita se cuide y se respete la intimidad de ALMA, de ella y Máximo. Se retira de la consulta más tranquila.

UCIN: Adecuación del esfuerzo terapéutico luego del nacimiento de ALMA

En reunión interdisciplinaria y multi-profesional neonatología, neurocirugía y cuidados paliativos se decide «no operar». Solo se ofrecen medidas de confort. Alimentación por vía enteral y paracetamol. Los últimos 4 días recibió morfina por sonda oro-gástrica. Fallece a los 14 días de vida con la presencia de ambos padres.

Conclusiones

Si bien la derivación al abordaje paliativo, parece facilitarse cuando hay mayor certeza diagnóstica de «letalidad», consideramos que una mayor presencia y visibilidad de los cuidados paliativos en el contexto perinatal optimizará nuestras intervenciones, favoreciendo la posibilidad, hoy apenas y tardíamente percibida, de las siguientes mejoras a favor de la familia y el bebé:

- ✓ Intervenciones interdisciplinarias propias con guías o recomendaciones para la toma de decisiones compartida con la familia en bebés con condiciones que limitan la vida.
- ✓ Aumento del conocimiento por parte de los profesionales, lo que disminuirá el temor de los profesionales a la atribución de responsabilidad legal, y con ello el ejercicio siempre despiadado de la ‘medicina defensiva’ (ej: adecuación del esfuerzo terapéutico, extubación compasiva, directivas anticipadas)
- ✓ Mejora en la derivación durante el período prenatal para generar mayor adherencia

al tratamiento y seguimiento posterior.

- ✓ Posibilidad de considerar las intervenciones en UCIN como una oportunidad de elaboración y prevención del duelo complicado.
- ✓ Manejo individualizado de cada situación, abordaje de la experiencia de enfermedad y no de una patología estandarizada.
- ✓ Manejo humanizado del nacimiento de bebés muertos intra-útero, con medidas de contención hacia la familia y apertura de espacios (físicos y virtuales) para favorecer el duelo generalmente silenciado.
- ✓ Ejercicio sistematizado, frecuente y sostenido del trabajo interdisciplinario: el equipo de salud debe aprender que la mirada de otra disciplina enriquece antes que entorpece las potenciales intervenciones. El paliativista reconoce esta necesidad: la interconsulta permanente es uno de los más saludables hábitos que se adquieren con su ejercicio.
- ✓ Posibilidad de adecuar el esfuerzo terapéutico sin que esto se instale como un dilema ético.

Los cuidados paliativos perinatales están diseñados para afirmar la existencia de «este bebé» y maximizar las oportunidades de cuidado por sus padres en el corto tiempo de vida.

El cuidado del duelo reconoce que las experiencias y sentimientos de los padres cuentan sin importar el tiempo de la gestación. Entendemos que ya sea antes o después del parto las intervenciones del equipo de cuidados paliativos apuntan a inscribir a este “bebé real” en una historia familiar para ser acogido como sujeto más allá de su pronóstico de supervivencia.

Referencias

1. Baker, J. *The Incubator and the Medical Discovery of the Premature Infant*. *Journal of Perinatology* 2000; 5:321-328.
2. Silverman WA. *A hospice setting for humane neonatal death*. *Pediatrics* 1982, 69(2): 239
3. Whitfield JM, Siegel RE, Glick AD et al. *The application of hospice concepts to neonatal care*. *Am J Dis Child*. 1982; 136(5):421-4.
4. Caitlin A, Carter B. *Creation of neonatal end of life care protocol*. *J Perinatol*. 2002; 22(5):184-195.
5. Calhoun BC, Napolitano P, Terry M, Bussey C, Hoeldtke NJ: *Perinatal hospice. Comprehensive care for the family of the fetus with a lethal condition*. *J Reprod Med* 2003, 48:343-348.
6. Leuthner SR. *Fetal palliative care*. *Clin Perinatol* 2004, 31(3): 649-65
7. *Ending preventable stillbirths. An Executive Summary for The Lancet's Series*. January 2016. <https://www.thelancet.com/series/ending-preventable-stillbirths> (Access 15 April 2020)
8. Cassidy P. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2018, 18:22 DOI 10.1186/s12884-017-1630-z
9. Balaguer A, Martín-Ancel A, Ortigoza-Escobar D, Escribano J, Argemi J. *The model of palliative care in the perinatal setting: a review of the literature*. *BMC Pediatr* 2012, 12: 25. doi: 10.1186/1471-2431-12-25.
10. Altimier, L, Phillips R (2016). *The neonatal Integrative Developmental Care Model: Advanced Clinical Applications of the Seven Core Measures for Neuroprotective Family-centered Developmental Care*. *Newborn & Infant Nursing Reviews* (16) 230-244
11. Milstein J. *A paradigm of integrative care: healing with curing throughout life, "being with" and "doing to"*. *J Perinatol* 2005, 25(9): 563-8
12. Feudtner C. *Collaborative Communication in Pediatric Palliative Care: A Foundation for Problem-Solving and Decision-Making*. *Pediatr Clin North Am*. 2007 October ; 54(5): 583-ix.
13. *Together for Short Lives* (2009) *The Neonatal Care Pathway*. <http://tinyurl.com/pncuwfj> (accessed 15 april 2020)
14. *British Association for Perinatal Medicine (2010) Palliative Care (Supportive and End of Life*
15. *Care). A Framework for Clinical Practice in Perinatal Medicine*.
16. *The Neonatal Care Pathway (2017). Change to The Perinatal Care Pathway*
17. Kiman R, Doumic L. *Perinatal palliative care*. *International Journal of Palliative Nursing* 2014, Vol 20, No 3
18. QMancini et al. *Neonatal Palliative Care for Nurses*. Springer Nature Switzerland AG 2020: 369-375.
19. Mancini et al. *Neonatal Palliative Care for Nurses*. Springer Nature Switzerland AG 2020: 369- 375. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31877-2_2

*Dra. Rut Kiman

Médica Pediatra. Magister y Especialista en Cuidados Paliativos. Instituto Pallium Latinoamérica. Asesora del Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento y Cuidado Perinatal (EICAP). Hospital Raúl Larcade. Docente del Departamento de Pediatría, UBA Medicina. Ex -Jefa del Servicio de Cuidados Paliativos- Servicio de Pediatría. Hospital Nacional Prof. A. Posadas

**Lic. Marianela Balanesi

Abogada. Lic. Especialista en Enfermería Neonatal. Miembro del Comité de Bioética del HIGA-HIEMI Mar del Plata, Docente de la Cátedra Salud del Niño, Niña y Adolescente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

RED DE NEONATOLOGÍA EN UN MUNICIPIO



Dr. Osvaldo Faustino Azpilicueta*

Sumario

Las redes de atención perinatal son la alternativa a la crisis del sector perinatal.

Las evidencias muestran que la regionalización perinatal es efectiva y eficiente para reducir la mortalidad maternoinfantil.

La fragmentación de los sistemas de salud es un problema que conduce a la inequidad e ineficacia de estos. Como respuesta, en décadas recientes se han conceptualizado, diseñado e implementado las redes integradas de servicios de salud.

Se han concebido como una red de servicios de salud a través de la cual se ofrece una atención coordinada y colaborativa en la entrega de prestaciones de salud, y cuyos objetivos se relacionan con mejorar la eficiencia global de los sistemas de salud y la continuidad de la atención.

Introducción

El proyecto de creación de la red perinatal del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es una estrategia de trabajo organizado en red que facilita el acceso a los servicios de salud de buena calidad de la embarazada y el recién nacido, y que tiene por finalidad dar respuesta a un grave problema de salud pública y derechos humanos como es la mortalidad materna y neonatal por causas evitables en la región.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual representa un estándar común que debe ser alcanzado por todos los pueblos y naciones basado en el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, y establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia sanitaria.

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 remarcó esta naturaleza única de la infancia y, por lo tanto, de la aplicación de los derechos concernientes específicamente a la infancia.

La mortalidad materna es definida por la Organización Mundial de la Salud como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”.

El 95% de los casos de mortalidad materna es evitable.

Según datos oficiales, la evolución de la mortalidad materna bonaerense muestra un ascenso alarmante en los últimos años.

A nivel mundial, la mayoría de las muertes maternas son por hemorragias, infecciones, hipertensión arterial no controlada del embarazo y el parto distócico.

En la provincia de Buenos Aires, los factores van desde demoras en la atención, hasta falta de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE).

La meta es llegar a 13 muertes al año, aunque obviamente la aspiración es llegar a mucho menos que las 123 muertes maternas que se registraron en el año 2015.

En la Argentina, han fallecido en el año 2001 más de 300 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Esto representa una tasa de 43 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. El 12% de estas mujeres es menor de 19 años. Además, hay regiones del país donde esta tasa se multiplica por tres o por cuatro. Si se considera que países con un índice de desarrollo humano similar, como Chile o Uruguay,

presentan tasas de mortalidad materna de entre 23 y 26 por cada 100.000 nacidos vivos, es evidente que estamos frente a un problema que puede y debe disminuir, en la medida en que se definan y desarrollen políticas coherentes y acciones sostenidas en el tiempo.

La mortalidad materna pone de manifiesto la violación de un conjunto de derechos de la mujer. Da cuenta de una cadena de vulneraciones de principios básicos, como el derecho a la vida y el acceso a información de calidad y al máximo nivel posible de salud. Para hacer frente a este problema, se requieren estrategias específicas para la atención de mujeres desde su más temprana edad y el compromiso comunitario, familiar y de los servicios de salud en pos de una maternidad segura.

Si bien la falta de insumos es un problema de carácter recurrente, los problemas de organización y de administración de recursos no son temas menores.

Consideramos que se pueden mejorar los logros en materia de calidad y cobertura en la atención a partir de una mejor organización del sistema de atención. En este sentido, la temática de accesibilidad es un tema central. Todo hecho que actúe como barrera de acceso tendrá su correlato negativo en términos de desenlaces no deseados de salud. A modo de ejemplo, la falta de acceso a la información, a la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma en salud sexual y reproductiva, a un sistema de servicios coordinados por complejidad asistencial son algunas de las barreras que impiden una coherencia entre la oferta y la demanda.

Sin lugar a dudas, las barreras financieras son las que más están afectando en la actualidad la posibilidad de satisfacer las demandas en materia de atención.

Desde el punto de vista contextual, las muertes maternas son, además, la expresión de la baja calidad de vida especialmente en grupos socialmente postergados y en situación de pobreza. No es casual que más del 90% de las muertes maternas, así como las infantiles, se concentre en el mundo en desarrollo.

Por cada mujer fallecida, son 30 las mujeres que quedan con secuelas asociadas del embarazo, el parto y el puerperio. Las muertes de mujeres condicionadas por problemas ocurridos durante el proceso reproductivo tienen consecuencias profundamente negativas para la fa-

milia y para la comunidad en general.

Dada la interrelación existente entre salud de la madre y la de sus hijas e hijos, evitar las muertes maternas implica además mejorar la salud de la niñez y su supervivencia.

Sin embargo, no resultan menores los condicionantes que subyacen a cada muerte y que denotan la existencia de inaceptables asimetrías, entre provincias y dentro de ellas, como expresión de inequidad. Estas asimetrías expresan además la falta de corresponsabilidad en los niveles de decisión vinculados con la salud y los derechos de la mujer se expresan en la falta de adecuación de los servicios de salud y de marcos regulatorios que aseguren la provisión de servicios de salud para la mujer.

Toda mujer tiene el derecho a un embarazo planificado y a un parto seguro y humanizado.

Por otro lado, la mortalidad neonatal es la fracción más importante de la mortalidad infantil. Si bien se ha producido un descenso de la mortalidad neonatal en los últimos años, esta permanece elevada. Además la mortalidad postneonatal depende en una proporción importante de causas neonatales, como el bajo peso al nacer, y de la morbilidad crónica derivada de la patología neonatal.

La prematurez al nacer constituye la primera causa de muerte infantil y, en la provincia de Buenos Aires, el 8% de los 280 mil nacimientos anuales se produce antes de lo esperado, es decir, de la semana 37 de gestación.

En la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, viven 450.000 personas, nacen 6000 bebés por año, 250 de los cuales pesan menos de 2000 gramos al nacer y para recibir atención adecuada deben trasladarse grandes distancias en condiciones no siempre buenas.

Setenta son los niños que mueren anualmente en la región del sudoeste antes de cumplir el primer año de vida.

Cincuenta y cinco niños de los setenta, el 80%, mueren en el período neonatal, el primer mes de vida.

Todo niño tiene el derecho a nacer en el nivel de complejidad que según su riesgo le corresponde.

Planteamiento del problema y justificación del proyecto. Regionalización perinatal: ¿por qué?

La MN es menor cuando los bebés de mayor

riesgo nacen en unidades de mayor complejidad.

Es posible lograr que más del 70% de los bebés de mayor riesgo nazcan en unidades especializadas.

La mortalidad de los bebés <1500 g depende de la experiencia de la institución tratante y del número de enfermeras por paciente crítico.

La proporción de médicos especializados que se requieren es menor en los sistemas regionalizados.

Este proyecto de creación de red perinatal del sudoeste de la provincia de Buenos Aires nace por el aumento de la demanda de la atención perinatal en el ámbito local y regional debido a múltiples factores.

El servicio de neonatología regional del Hospital Municipal de Coronel Suárez se encuentra ubicado en un lugar estratégico en el sudoeste de la provincia y no existe otro centro neonatal ni del sector público ni del privado en un radio de 200 Km. Las neonatologías más próximas son: al sur, Bahía Blanca; al este, Necochea; al norte, Azul; y al oeste, Santa Rosa.

Durante las últimas tres décadas, asistimos a numerosos neonatos enfermos con buenos resultados de morbilidad. Sumado esto a lo difícil que es conseguir una cama para un recién nacido enfermo, a nuestra ubicación geográfica y a las grandes distancias que nos separan de los centros de alta complejidad, nos convertimos en un lugar de referencia de 22 hospitales vecinos, de tres regiones sanitarias (la I, II y IX). Pero la asistencia neonatológica moderna demanda cada vez más, necesita mejor organización, mayor complejidad y recursos humanos más capacitados y actualizados y por esto debemos trabajar en red.

Si bien muchos de los factores que contribuyen a mejorar las estadísticas perinatales son de carácter socioeconómico, educativo o político, también es muy importante brindar asistencia médica adecuada al neonato enfermo en tiempo y forma, porque la experiencia demuestra que la mortalidad en la primera semana de vida en hospitales que disponen fácilmente de acceso a una unidad de asistencia neonatal intensiva es menos de la mitad que la observada en hospitales que no tienen esa opción.

Considerando que más de la mitad de las muertes pediátricas en la actualidad ocurren en el período neonatal, deben ampliarse el tiempo y el esfuerzo dedicados a la atención de estos niños.

Del análisis de las muertes neonatales según

criterios de reducibilidad, surge que el 60% de esas muertes podrían haberse evitado con un diagnóstico y/o tratamiento oportuno. Cuando analizamos las muertes neonatales según el peso al nacer, se observa que gran parte de los recién nacidos que fallecen pesaron menos de 2500 g. Así, un reducido número de niños es el responsable de la mayoría de las muertes. Esto enfatiza que la primera causa asociada a la muerte neonatal es la prematuridad.

En Argentina nacen aproximadamente 700.000 niños por año y más de la mitad nacen en instituciones de menos de 50 camas, como los hospitales de la región del sudoeste.

La mortalidad neonatal va en lento descenso, de 18,7 por mil en 1980 a 10,2 en 2015

7000 recién nacidos mueren por año en sus primeros 7 días de vida.

El 60% de las causas de mortalidad son causas reducibles.

El 60% de 7000 = 4200 recién nacidos no morirían con las siguientes propuestas

PROPUESTAS QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD:

- TRABAJAR EN RED.
- Unificar centros de atención neonatal con diferentes niveles de complejidad asistencial.
- Trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Registrar y analizar los resultados.
- Realizar prácticas basadas en la evidencia.
- Respetar las necesidades de la familia.

PROPUESTAS QUE REQUIEREN PRESUPUESTO PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD:

- Financiamiento de la red.
- Recursos humanos.
- Recursos tecnológicos.

Si queremos mejorar el cuidado de nuestros recién nacidos, tenemos que priorizar el cuidado perinatal, estableciendo un proyecto de atención para dicha población y así veremos una disminución de la mortalidad infantil.

El factor crítico para proporcionar servicios de alta calidad no es la aparatología sofisticada, ni

grandes salas para internación, ni ambulancias de última generación o aviones sanitarios para transporte. El factor crítico es el factor humano, es el personal entrenado y con experiencia en las mejores técnicas profesionales del cuidado de recién nacidos, que trabaje en servicios de neonatología en un plan regional para proporcionar este cuidado.

Es prioritario convencer a los administradores de que en el área perinatal lo urgente no siempre es lo más importante y que los servicios de neonatología no son solo incubadoras y respiradores.

Los requisitos para una unidad eficaz de asistencia neonatal intensiva son estrictos en lo que se refiere a lo siguiente:

- Disponibilidad de personal cabalmente adiestrado.
- Planta física correctamente habilitada.
- Aparatología.
- Financiamiento adecuado.

FINALIDADES DE LA REGIONALIZACIÓN PERINATAL

Disminuir la morbilidad materno-infantil y garantizar el acceso igualitario a los servicios de salud

El concepto de regionalización, relacionado con la neonatología, es que una zona definida de población (en nuestro caso la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires) se estudia en cuanto a características socioculturales, geográficas, económicas, de transporte y facilidades médicas y de pacientes, para determinar los cambios que pueden hacerse con el fin de asegurar un cuidado óptimo para su neonato y así disminuir la mortalidad infantil.

Este concepto de regionalización implica una consolidación de la atención a neonatos enfermos a nivel de los hospitales municipales, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención.

La génesis del centro de referencia regional depende de que sea poco prudente, o imposible, que todos los hospitales municipales proporcionen todos los tipos de especialización para cuidados de sus pacientes. El enorme costo y la rareza de capital económico y humano pueden considerarse un motivo de ello. Por lo tanto, el centro de referencia regional proporciona un claro ejemplo de cooperación profesional que cubre los fines importantes de integración con experiencia compartida, poca duplicación de

servicios y costos controlados.

La alternativa obvia de la duplicación de servicios es compartirlos.

Se estima que el principio de eficiencia, salvar la vida de los neonatos enfermos, sin secuelas y con los costos sociales, humanos, profesionales y económicos más bajos, sigue siendo la razón de la regionalización asistencial perinatal. El traslado de los pacientes a los hospitales donde se encuentren los recursos de personas y material convenientes y apropiados para su atención y cuidado específico es la forma idónea para conseguirlo.

El desarrollo y la calidad de la regionalización se apoyan en unos principios doctrinales que son válidos y sustanciales para cualquier tipo de planificación y organización asistencial.

Regionalización perinatal es el desarrollo dentro de un área geográfica de un sistema de salud materno y neonatal coordinado en el cual, merced a acuerdos entre instituciones y basándose en las necesidades de la población, se identifica el grado de complejidad que cada institución provee con el fin de alcanzar los objetivos:

- Reconocimiento y atención de calidad para todas las gestantes y nacidos de alto riesgo.
- Coordinación entre los hospitales regionales con una organización y dotación apropiada de estos según niveles de complejidad.
- Personal perinatal altamente entrenado y en número adecuado.
- Traslado de embarazadas o recién nacidos a los centros adecuados según sus necesidades asistenciales.
- Utilización adecuada de la tecnología requerida.

Estos principios llevan implícitos programas informativos, docentes y científicos que contribuyan a mantener los objetivos de eficiencia y calidad de la regionalización perinatal.

Nacen anualmente en nuestra región del sudoeste alrededor de 6000 niños y se trasladan, desde el hospital donde nacieron a uno de mayor complejidad, más de 150 por año.

Razón más que suficiente para una organización regionalizada de la asistencia perinatal.

La demanda asistencial de los municipios limítrofes justifica que esta englobe el Centro de Neonatología Regional de Coronel Suárez.

En la actualidad, en la Región del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se carece de un programa asistencial perinatal.

En estos últimos años se ha producido un estancamiento en el descenso de nuestras cifras de mortalidad perinatal, tanto fetal como neonatal, manteniéndose por encima de otros entornos mejor organizados y con similares recursos. A esta paralización contribuyen de forma sustancial las poblaciones de neonatos de muy bajo peso, menores de 1500 g. En la actualidad, estas poblaciones son una parte sustancial del espectro de niños hospitalizados y de las estancias en los servicios de neonatología. Pacientes cuyas patologías requieren grandes recursos de personal y material.

La oferta numérica de camas de cuidados intensivos y medios que actualmente ofrecen los hospitales de nuestra región debe ser reevaluada y, en su caso, redistribuidas según la planificación que se estima más apropiada para las necesidades asistenciales que se determinen en el plan regional de asistencia perinatal.

Se carece de una adecuada coordinación interhospitalaria, así como de una calificación de niveles asistenciales.

Gran parte de las dotaciones actuales de equipamiento son insuficientes y obsoletas. Un número importante de estos tienen más de 20 años de uso.

El número total de enfermeras se considera insuficiente, así como la relación personal entrenado/personal en formación. Igualmente se estima excesiva la proporción personal auxiliar/enfermera.

Aunque el transporte ha mejorado últimamente, se siguen detectando insuficiencias. El transporte desde las regiones limítrofes presenta, con frecuencia, serias y graves deficiencias.

Prácticamente se carece de una política de registros de morbilidad y datos de orden epidemiológico. Esta carencia es total en el área asistencial no pública.

La regionalización perinatal es una necesidad perentoria en la actual situación de nuestra región para cuya solución se requieren acciones políticas, de actualización de las dotaciones de recursos humanos, de equipamiento y continuar mejorando el sistema de transporte.

Mejorar los sistemas de comunicación entre los hospitales de la región con el fin de optimizar los recursos, facilitando el desplazamiento

de los pacientes (ida y vuelta).

Mejorar la colaboración interprofesional y atender las necesidades de los niños tanto asistenciales como familiares.

Desarrollar una política informativa de registros de morbilidad, deficiencias y datos epidemiológicos que sean de obligado cumplimiento en todos los servicios de obstetricia y neonatología, tanto del sector público como privado.

Crear una unidad administrativa que coordine y, en su caso, establezca la política de implantación, desarrollo y funcionamiento de la regionalización en la región.

Establecer normas de obligado cumplimiento sobre los mínimos de material, personal y estructura de los servicios de neonatología.

Estimular y apoyar programas docentes y de investigación en el área perinatal.

ÁREA DE TRABAJO EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Recibimos neonatos de 22 distritos de tres Regiones Sanitarias (I-II-IX) que abarcan un área amplia como la cuarta parte de la provincia, donde vivimos 450.000 personas y nacen 6000 niños por año (tasa de natalidad 15‰). No existe otro centro neonatal en un radio de 200 km ni en el sector público ni en el privado.

- ✓ Carhué
- ✓ Casbas
- ✓ Coronel Suárez
- ✓ Guaminí
- ✓ Benito Juárez
- ✓ Carlos Tejedor
- ✓ Coronel Dorrego
- ✓ Coronel Pringles
- ✓ Gonzales Chaves
- ✓ Daireaux
- ✓ General La Madrid
- ✓ Henderson
- ✓ Huanguelén
- ✓ Laprida
- ✓ Pellegrini
- ✓ Rivera
- ✓ Bolívar
- ✓ Puan
- ✓ Pigüé
- ✓ Salliquelo
- ✓ Tres Arroyos
- ✓ Tres Lomas

Acciones para formalizar la red. ¿Cómo organizar la regionalización de la Asistencia perinatal?

La red estará integrada por todos los establecimientos públicos municipales y provinciales — incluyendo los privados cuando su importancia lo justifique— ubicados en la zona de cobertura geográfica del Hospital Municipal de Coronel Suárez y del Hospital Interzonal General Dr. José Penna, de la ciudad de Bahía Blanca, que cumplan funciones de servicios de atención de la salud en los tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo con un criterio pautado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y consensuado con las secretarías de salud de cada uno de los municipios intervinientes.

Es una decisión política formalizar la red.

Es imprescindible contar con un diagnóstico de situación sociosanitaria, incluyendo los siguientes aspectos:

- Una población definida.
- Saber quiénes somos: actores, instituciones, sistema de información. historias de arrastre organizacional, resistencias al cambio, conflictos de intereses.
- Un área territorial con límites precisos, comunicaciones, transportes, geografía, costumbres.
- Organismos efectores.
- Un plan de Salud.
- Una fuente de financiamiento.
- La coordinación de todos los recursos disponibles como mecanismo para su maximización.
- Un rol fundamental de todos nosotros es sensibilizar y motivar sobre las acciones por realizar y explicar la necesidad de cambio.
- Conformación de equipos de trabajo (Nación-Provincia-Municipios).
- Relevamiento de los recursos humanos y de equipamiento de cada uno de los integrantes de la red.
- Evaluar Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE). OMS 1986.
- Elaboración de cronograma de trabajo para:
 - Definir los niveles de complejidad de cada hospital.
 - Diseño de sistemas de comunicación.
 - Diseño de sistemas de traslado maternoinfantil.



- Consenso en protocolos de derivación (referencia y contrarreferencia).
- Visitas periódicas para seguimiento y revisión de logros y metas.

Entre todos los actores tenemos que planificarla y armarla en niveles de complejidad para la atención materna y neonatal.

NIVELES DE COMPLEJIDAD. Definir niveles de complejidad en cada uno de los integrantes de la red.

Nivel I: atención del embarazo y parto de bajo riesgo. Identificar el riesgo y referencia oportunos.

Nivel II: atención del embarazo y parto de mediano y alto riesgo.

Nivel III: centro perinatal.

Nivel IV: centro de alta complejidad (cirugía cardiovascular, neurocirugía).

Nivel I

- ✓ Proporcionar la reanimación neonatal en cada parto.
- ✓ Evaluar y proporcionar atención postnatal a los bebés recién nacidos estables.
- ✓ Estabilizar y cuidar de bebés de 35 a 37 semanas de gestación que son fisiológicamente estables (con límites y guías).
- ✓ Estabilizar a los recién nacidos que están enfermos o que hayan nacido antes de las 35 semanas de gestación hasta el traslado a un más alto nivel de atención.

Nivel II

- ✓ Capacidades del nivel I.
- ✓ Proporcionar atención integral a los niños nacidos antes de las 32 semanas de gestación y peso menor de 1500 g.
- ✓ Proporcionar una gama completa de soporte respiratorio que puede incluir la ventilación convencional y/o ventilación de alta frecuencia.
- ✓ Proporcionar soporte vital sostenido.

Nivel III

- ✓ Capacidades del Nivel II.
- ✓ Proporcionar soporte vital sostenido.
- ✓ Proporcionar atención integral a los niños nacidos prematuros y con enfermedad crítica.
- ✓ Proporcionar una gama completa de soporte respiratorio que puede incluir la ventilación convencional y/o ventilación de alta frecuencia y el óxido nítrico inhalado.
- ✓ Proporcionar un acceso rápido y fácil a una amplia gama de subespecialistas pediátricos (cirujanos, anestesistas, oftalmólogos).
- ✓ Realizar estudios de imágenes con carácter de urgencia (RMN, TAC, ECG).

Nivel IV

- ✓ Capacidades del nivel III.
- ✓ Ubicado dentro de una institución con la capacidad de proporcionar una reparación quirúrgica del RN con patología congénita compleja o condiciones adquiridas.

- ✓ Mantener una amplia gama de subespecialistas médicos pediátricos, subespecialistas en cirugía pediátrica y anestesiólogos pediátricos en el sitio.
- ✓ Facilitar el transporte y proporcionar educación y divulgación.

METAS y DESAFÍOS

- ✓ Empoderar a la comunidad para que ejerce sus derechos.
- ✓ Implementar el Programa de Garantía de la Calidad de Atención Médica.
- ✓ Lograr que en todas las jurisdicciones de la región se organice la regionalización perinatal.
- ✓ Conformación de un servicio de obstetricia en Coronel Suárez con alcance regional.
- ✓ Lograr que el 100% de los partos institucionales se realicen en maternidades con CONE y según complejidad.
- ✓ Reducir partos electivos antes de las 39 semanas.
- ✓ Lograr los mejores estándares de calidad de atención materno y neonatal: acreditar servicios y hospitales.
- ✓ Organización de un servicio de transporte materno- y neonatal de alta complejidad.
- ✓ Concretar un sistema de traslado aéreo regional.
- ✓ Crear una unidad administrativa que coordine el funcionamiento de la red.
- ✓ Incluir al sector privado en el proyecto de regionalización perinatal.
- ✓ Puesta en marcha del SIP-Gestión, y del Módulo Neonatal en toda la región.
- ✓ Mejorar el acceso y la calidad de la atención con el uso de la telemedicina.
- ✓ Casa de madre para la espera del parto.
- ✓ Desarrollar trabajos de investigación.
- ✓ Limitar el número de terapias neonatales en una región a la necesidad real.
- ✓ Mejorar la calidad de los servicios existentes antes de crear nuevos.

Conclusiones

El trabajo en red es una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio entre instituciones y/o personas que deciden asociar voluntaria o concertadamente sus esfuerzos, experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes. Constituye una modalidad organizativa y de

gestión que adoptan los miembros que deciden esa vinculación cuyas características dominantes son la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad de las relaciones.

La esencia del trabajo en red es la decisión de una o más personas, instituciones o áreas institucionales de desarrollar una tarea en común, en procura de objetivos compartidos explícitos, manteniendo la identidad de los participantes.

Las redes nos preexisten, preceden nuestra llegada y nuestra intervención, ya que constituyen la trama misma que entreteje la vida.

“La red es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales, aportando los atributos de contención, sostén, posibilidad de manipulación, tejido, estructura, densidad, extensión, control, posibilidad de crecimiento, ambición de conquista, fortaleza, etc., tomados en préstamo de su modelo material. El término es aplicable a dos fenómenos diferentes: por una parte, a un grupo de interacciones espontáneas en un cierto contexto definido por la presencia de ciertas prácticas más o menos formalizadas; por otra parte, puede también aplicarse al intento de organizar esas interacciones de un modo más formal, trazarles una frontera o un límite, poniéndoles un nombre y generando así, un nuevo nivel de complejidad, una nueva dimensión”.

Este campo de la asistencia médica difiere mucho de los demás, por lo cual solo puede ser atendido adecuadamente por personas especialmente adiestradas dentro de una organización específicamente planteada y equipada para este fin.

Solo el desarrollo selectivo con líneas regionales es práctico o eficaz para disminuir de manera importante la mortalidad y la morbilidad. Se obtendrán resultados óptimos si esta evolución ocurre dentro del contexto de un amplio plan para brindar dicha asistencia.

Tenemos mucho por hacer, es necesario crear un sistema de redes perinatales y trabajar en él, a fin de lograr estándares mínimos que permitan un cuidado efectivo y una producción que genere una disminución de la mortalidad infantil y materna en nuestra región.

La implementación de este proyecto es una acción de bajo costo y de alto impacto sociosanitario. Aún existen algunas barreras para formalizar la red y cambiar el concepto de que esta es mucho más que una ambulancia que traslada enfermos a un centro de mayor complejidad.

Bibliografía

- *Acute Care of at Risk Newborns. ACORN: La manera sistemática de enfocar la estabilización del recién nacido en riesgo.* Acorn; 2010.
American Academy of Pediatrics. Guidelines perinatal care. 7ª ed. New York: AAP; 2012.
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE).
Dabas EN, Yanco, D, Ros C. La intervención en redes sociales y fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires; 2001.
Lemus J, Casserly P. Programas médicos comunitarios. Posgrado en salud social y comunitaria.
Ministerio de Salud de la Nación. Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia [en línea]. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2015. [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: <http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-normal.pdf>
Ministerio de Salud de la Nación. Regionalización de la atención perinatal. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2011.
Ministerio de Salud de la Nación. Norma de organización y funcionamiento de Servicios de Maternidad. Aprobada por Resolución Ministerial N° 348/03. Argentina. 2013.
Ministerio de Salud de la Nación. Normas de Organización y Funcionamiento de Servicios de neonatología. Aprobada por Resolución Ministerial N° 306/02. 2012.
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo [en línea]. La Plata: Ministerio de Salud; s.f. [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: <http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/04/Guia-Control-de-Embarazo-Parto-y-Puerperio-debajo-riesgo.pdf>
Sociedad Argentina de Pediatría. Curso de Reanimación Neonatal Avanzada.
Speranza A. Maternidad segura y centrada en la familia. MSCF en el marco de la regionalización perinatal.
Unicef Argentina. Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de los niños y niñas desde el período del embarazo hasta los 5 años [en línea]. Buenos Aires: Unicef; 2015. [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: [https://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD_PBPrimerInfancia_web\(1\).pdf](https://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD_PBPrimerInfancia_web(1).pdf)
UNLP. Facultad de Ciencias Médicas. Curso de capacitación en gestión y evaluación de la calidad en salud.
Yu V, Dunn P. Development of regionalized perinatal care. 2004.

*Dr. Osvaldo Faustino Azpilicueta

Especialista en Pediatría y Neonatología. Magíster en Administración de Servicios de Salud. Universidad Favaloro. Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de Coronel Suárez. Ex Director Asociado de Región Sanitaria I. ofazpilicueta@hotmail.com

CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD BUCAL



DRA. SARA FÉ DE LA MELLA QUINTERO*

Sumario

Una dentición sana y funcional es importante en todas las fases de la vida al permitir funciones esenciales tales como el habla, la sonrisa, la socialización o el comer. Una boca sana y un cuerpo sano van de la mano. Por el contrario, una mala salud bucodental puede tener consecuencias desfavorables en el bienestar físico y psicosocial a cualquier edad, por ello en la Ficha técnica sobre salud bucodental, OMS 2012 se define que “La salud bucodental es esencial para la salud general y la calidad de vida.” Analizaremos los vectores de estas prácticas.

Introducción

Vida que comienza con la concepción donde precisamente en la sexta semana de vida intrauterina la formación de los dientes se hace evidente, y es cuando apenas personas logran saber del embarazo. En este periodo la prevención de afecciones bucodentales es definitorio ya que pueden ocurrir situaciones que marcan el desarrollo dental para toda la vida por ello es mejor que la:

Alimentación sea balanceada (aportes necesarios de calcio y vitaminas), tomarlo como un estilo de vida antes de la concepción y no una necesidad por el embarazo.

Mantener correcta higiene bucal es importante, pues elimina de la boca bacterias que incluso pueden ser las causantes de abortos y partos prematuros. Vigilar estado de encías y dientes es fundamental.

Visitar al odontólogo frecuentemente. Al menos cada 6 meses. Si es necesario por la condición médica dental debe hacerlo cada tres meses, quincenal o semanal.

Información sobre la importancia de la lactan-

cia materna para el desarrollo de su futuro bebé. Esta debe ir cargada de beneficios para toda la familia. Explicarla no solo desde el punto de vista económico sino también desde la inmadurez del sistema digestivo para aceptar otro tipo de leche, la inmunidad que se desarrolla, así como el fortalecimiento del sistema estomatognático son aspectos importantes que descuidamos creyendo que no serán bien acogidos. La falta de información IMPORTANTE prima en embarazadas, pero el convencimiento de esta labor tan esencial debe partir de los profesionales de la salud, educar no es fácil, pero debemos tener el convencimiento de que

“... la salud bucodental se refiere a la salud de nuestra boca y en definitiva apoya y refleja la salud de todo nuestro cuerpo.” Regina Benjamín, Cirujana de Estados Unidos, 2010

Una vez que ha nacido él bebé es a dos personas y no a una a la que debemos cuidar, pensamos que mientras la madre amamanta a su bebe todo estará resuelto, pero ¿y el cuidado de la salud bucal del recién nacido? ¿y su salud bucal hasta los cuatro años? En estas etapas la atención de la salud bucal de la madre sigue siendo primordial. La transmisión de bacterias desde su cavidad hacia la del niño determinará su salud bucal y general rápidamente.

No solo la transmisión de afecciones bucales sino también de origen respiratorio generalmente proviene de la madre o familiares que limpian chupetes con su saliva o dan besos intensos de boca a boca.

Si bien es cierto que autores describen la importancia de transmisión de microorganismos la mayoría alega que el contagio de estreptococos mutans causante de la caries dental se transmite por esta vía por lo que la colonización de bac-

terias patógenas se inicia en esta etapa. Sigue siendo entonces:

La higiene oral y alimentación balanceada de la madre y del bebé: aspectos importantes en esta etapa

- Importancia de la lactancia materna para el desarrollo correcto de maxilares y sistema digestivo en general.

- Higiene oral del bebé incluso antes del brote dentario. Es un mito que no se higienice la boca porque no hay dientes o porque él bebe aun no ingiere otro alimento que no sea leche materna o artificial. La higiene de cavidad con dedal de gasa es importante en esta etapa de la vida

- Evitar hábitos perjudiciales para el bebé. Aquí no solo es importante el uso de biberones y chupetes, sino también la postura a la hora del sueño, nunca debemos permitir que él bebe duerma con los brazos debajo de la cabeza esto facilita el desarrollo desigual de estructuras musculares y óseas. Por otra parte la succión digital es algo debatido y en esta etapa no constituye una preocupación.

- Introducción de alimentos adecuados para mantener la musculatura adecuada. El uso de tecnología para triturar alimentos hasta quedar batidos totalmente ha iniciado un desajuste en la musculatura facial de los individuos, adecuar alimentos para que sean ingeridos con la textura adecuada sin demasiada cocción o trituración debe ser algo que enseñemos a las madres desde etapas tempranas.

Las enfermedades bucodentales, como todas las otras existen una gama de factores de riesgo. Algunos, como la edad, el sexo y las condiciones hereditarias, son intrínsecos a la persona y no se pueden cambiar o modificar. Otros, que están sujetos a los comportamientos y estilos de vida, se consideran factores de riesgo modificables, ya que la acción individual y la modificación de un hábito o comportamiento particular es posible, sin embargo este cambio puede ser difícil de lograr sin intervenciones y apoyo adicionales. Los factores de riesgo modificables de las enfermedades bucodentales incluyen una dieta poco saludable, particularmente aquella alta en contenido de azúcar, cuidar de que estas y otros alimentos estén de manera balanceada o nula en la alimentación es tarea de toda la familia. Es importante destacar que estos factores de riesgo también se comparten con la mayoría de las otras enfermedades no transmisibles principales.

En la etapa Pre escolar la salud bucal no deja de ser una preocupación ya que es en esta etapa donde ocurren desarrollos acelerados y donde además de las caries, la enfermedad gingival así como las anomalías de la oclusión empiezan a hacer estragos en la boca del niño o niña por ello sigue siendo fundamental:

- Alimentación balanceada. Introducir alimentos desde edades tempranas ricos en calcio, flúor, fósforo, también es importante en esta como en otras etapas pues como mencionara Margaret Chan, Directora General OMS, 2014 “Algo va mal. Parte de nuestro desequilibrado mundo muere de hambre, mientras otra parte se lanza a sí misma a un nivel de obesidad tan extendida que está haciendo retroceder las cifras de esperanza de vida”, esta acumulación de comida chatarra con exceso de carbohidratos y azúcares constituyen factores de riesgo importantes de las enfermedades bucales

- Corregir todo tipo de hábitos (incluir posturales) le corresponde a la familia y al médico de cabecera diagnosticar y tratar tempranamente hábitos que pudieran ser perjudiciales, succión digital, respiración bucal, onicofagia, biberón, chupetes, queilofagias, entre otros.

Higiene oral del infante

En esta edad la supervisión es importante, si bien es bueno que se desarrolle independencia en estos aspectos la limpieza de la cavidad oral debe ser supervisada por un adulto que compruebe el éxito de la misma.

- Medicamentos en la prevención de la caries. Este tema puede resultar controversial donde médicos y odontólogos pudieran estar o no de acuerdo, no obstante a pesar de que la higiene constituye la base fundamental en la conservación de la salud bucal, la aplicación de medicamentos desde la prevención pueden también contribuir a la no aparición de lesiones cariosas incipientes. Todo esto bajo supervisión de un profesional.

- Visita al odontólogo al menos cada 6 meses. Estas visitas necesarias pudieran extenderse en el tiempo si se analizan adecuadamente y se individualizan a los pacientes

- Prevención de las caídas y golpes. En esta etapa los juegos suelen ser más activos necesitan ser vigilados de manera general pues la curiosidad los lleva a situaciones que pudieran poner en peligro su vida pero también su salud bucal, es aquí donde comienzan muchas veces

afecciones que se descubren incluso en etapas posteriores, y que dan como resultado la pérdida de vitalidad dentaria o la avulsión en la cual el diente no puede ser reimplantado.

Según se avanza en la edad, surgen otras preocupaciones y otras acciones para enfrentarlas. Los métodos de prevención no cambian sino que se modifican teniendo en cuenta muchas veces la psicología de las edades. Tal es así que en la edad escolar sigue siendo importante:

- Visita al odontólogo. Cada 6 meses. Individualizar al paciente y de ser necesario acortar el periodo entre citas.

- Mantener la higiene bucal sigue siendo una máxima pero con motivaciones diferentes, incentivar en el niño o niña este hábito como parte no solo de su salud sino también de su estética, demostrarle la importancia para prevenir afecciones y la halitosis suele ser necesario.

- Alimentación balanceada no deja de ser una prioridad más aun cuando en esta etapa los alimentos chatarra pasan a ser sus preferidos y además muchas veces invaden nuestras casas. No se trata de no consumirlos sino de enseñarle horarios, porciones, y acciones que se deben realizar cuando se consumen como es el caso del cepillado dental. Demostrarles que no son beneficiosos para su salud también es una tarea de todos.

- Prevención de maloclusiones, traumas dentarios. En esta etapa incluso se inician en deportes que pudieran ocasionar algunas caídas y fracturas dentales, utilizar medios de protección o contención resulta imprescindible. Así mismo los hábitos instaurados en otras etapas sino fueron eliminados deben erradicarse y colocarse tempranamente aparatos de ortodoncia removibles que ayuden a la musculatura y al hueso a un mejor crecimiento y desarrollo.

- Prevención de la caries con medicamentos de uso odontológico. En esta etapa realizar tratamientos preventivos en dentición permanente resulta de vital importancia, siempre bajo la supervisión de un profesional.

La Adolescencia es una etapa bien definida del ciclo vital humano entre la niñez y la adultez, y se caracteriza por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales, es considerada como una de las etapas más sanas de la vida, y aunque no deja de ser cierto, es también una de las más complejas por ello garantizar la salud bucal es también una ardua tarea. Aspectos vi-

sibles en etapas anteriores son también utilizados en esta para garantizar la salud integral tal es el caso de:

- Alimentación balanceada, visita al odontólogo, prevención traumas y mantener la higiene bucal, todas con un enfoque dirigido a la estética por ser un aspecto importante en la vida de los jóvenes, sin menospreciar la salud.

- Prevención de hábitos tóxicos. En este aspecto el hábito de fumar, la ingestión de bebidas alcohólicas entre otros son aspectos esenciales que se deben trabajar para prevenir, insistiendo siempre en los daños que ocasiona a la salud bucal y todas las posibles afecciones que traen consigo.

- Trasmisión de enfermedades de transmisión sexual por vía oral. A veces se encuentran tabúes, pero resulta importante este aspecto, debido a que por el desconocimiento surgen afecciones que repercuten en la salud general.

La etapa de la adultez posee otros retos significativos, es donde el trabajo colma la mayor parte del tiempo y por ello a veces se descuida la salud, como bien planteaba Helen Clark administradora de desarrollo de Naciones Unidas en 2011. "Las enfermedades bucodentales son un obstáculo al desarrollo. Algo tan prevenible como la caries dental, puede poner en peligro la capacidad de las personas para comer, interactuar con los demás, o asistir a la escuela o al trabajo. Todas estas consecuencias van en detrimento del bienestar humano, del desarrollo económico potencial y del progreso en el desarrollo." De ahí que el cuidado de la salud bucal sea tan importante. En esta etapa, como en otras:

- Alimentación balanceada, mantener la higiene bucal y visita al odontólogo cada 6 meses, son aspectos importantes.

- Importancia del mantenimiento de los dientes en la cavidad bucal. Informar a los adultos en este tema pudiera considerarse primordial, en esta etapa por cuestiones señaladas con anterioridad se prefiere la extracción dental ante cualquier dolor sin medir consecuencias como son las limitaciones funcionales por la falta de dientes, así como trastornos digestivos asociados.

- Influencia de hábitos nocivos en la salud bucal y mantener información sobre el cáncer bucal. Estos aspectos son de vital importancia, ya que mantener vigilancia y realizar una detección

precoz son armas útiles para el médico de la comunidad así como para el odontólogo.

“La mejora de la salud bucodental, al igual que la mejora de la salud general, deben ser disfrutadas por todos en la sociedad....”, estas palabras publicadas por Michael Marmot, Profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Londres en 2010 van muy a tono con el cuidado de la salud bucal del Adulto mayor, que no por haber vivido diferentes décadas se debe abandonar en la prevención de afecciones bucales para mantener una calidad de vida satisfactoria. Por ello aspectos repetidos en etapas anteriores concuerdan muy bien con la visión de un cuidado integral, ellas son:

- Alimentación balanceada, mantener la higiene bucal, visita al odontólogo cada 6 meses, información sobre el cáncer bucal, así como la influencia de hábitos nocivos en la salud bucal.

- Importancia de la higiene de la prótesis dental. En esta etapa la información precisa es importante, recalcar la retirada nocturna, como mantenerla limpia y su cambio cada 5 años más o menos son cuestiones que no deben faltar. Si no se tiene prótesis y existe la ausencia de dientes, la importancia de la rehabilitación es también oportuna.

NO OLVIDE REVISAR LA BOCA DE TODA LA FAMILIA, CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA VIDA TIENE ASPECTOS DISTINTIVOS DONDE PODEMOS REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES.

Bibliografía

- Colectivo de autores. *Guías alimentarias para niñas y niños cubanos hasta 2 años de edad. Documento técnico para los equipos de salud. Ciudad de la Habana. 2009.* pag 56-89.
- Colectivo de autores. *Promoción de salud bucodental y prevención de enfermedades. En: Sosa Rosales MC, Garrigó Andreu MI, Díaz Solorzano D, González Naya G, Llanes Llanes E. Guías prácticas de estomatología. La Habana: Ciencias Médicas; 2003*
- Glez Naya. G, Montero del C.ME. *Estomatología General Integral Cap 4 Pág. 43-47. La Habana .Editorial Ciencias Médicas. 2013. Parte II pag 42*
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S003475072003000100008&script=sci_arttext.
- Otaño Lugo R. *Ortodoncia. Cap 3 y4. La Habana. Editorial Ciencias Médicas. 2014.*
- *Prevención y salud bucal. Rev Cubana Estomatol 2008;(consulta :15 de febrero del 2018) .Disponible en: <http://www.ceacmf.cl/manual-prevencion.doc>.*
- *Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a la población. Anexos 8, 16,17 y 21. Dirección Nacional de Estomatología. Cuba: Ministerio de Salud Pública. 2013.*
- Ramos-Hurtado I T-RL, de-la-Mella-Quintero S. *Promoción de salud bucal en niños de un círculo infantil y una escuela primaria. Mediacentro Electrónica [Internet]. 2015 citado 2018 Feb 20; 19(2);[aprox. 3 p p.]. Available from: <http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/1371>.*
- Rodríguez Calzadilla A, Valiente Zaldívar C. *Estrategias y resultados de la atención estomatológica a niños y adolescentes. Rev Cubana Estomatol (Internet), 2013.*
- Valdés Álvarez. R *Manual de odontopediatría. Cap 2 pag 20.La Habana .Editorial Ciencias Médicas. 2014.*

* Dra. Sara Fé de la Mella Quintero

Dra. En Estomatología. Especialista de 1er y 2do grado en Estomatología General Integral. Msc. en Salud Bucal Comunitaria.

Profesora auxiliar e investigadora agregada. Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Cuba.

PEDIATRÍA Y MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA: HACIA UN MODELO DE TRABAJO INTEGRADO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN



DRA. JACQUELINE PONZO*

DR. WALTER PÉREZ**

Sumario

El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la atención de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva epidemiológica, bio demográfica y social que ofrece la región. Nos mueve la búsqueda de respuestas y propuestas para mejorar la organización asistencial y la formación de especialistas.

Este texto surge de experiencias y trayectorias uruguayas compartidas en los ámbitos del sistema de salud y de la Universidad de la República en Uruguay. La última década ha estado marcada por la reforma sanitaria que llevó a la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (2008).

Los caminos de la Pediatría y la Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC) han sido confluentes unas veces, paralelos otras, y también divergentes, con desencuentros. El escenario ha sido complejo y dinámico, pero esto mismo lo ha hecho muy enriquecedor.

Antecedentes

En Uruguay la Pediatría nace cuando aún no se había instalado la hegemonía de las especialidades en la medicina occidental. Se instala como una especialidad complementaria a la medicina interna del adulto y comparte con esta su vocación generalista, integral, a diferencia de la fragmentación característica de las especialidades “flexnerianas”.¹

La MFYC nace en el Programa Nacional de Residencias Médicas en Uruguay en 1997. Se pueden reconocer antecedentes precursores de la especialidad, entre ellos un Programa de Medicina Familiar en la órbita del Ministerio de Salud Pública creado por Ley en 1987 que contaba con algo más de cien cargos de médicos de familia, aunque la especialidad no existía en el país.

La Facultad de Medicina (Universidad de la República) es parte y escenario de los procesos de desarrollo de ambas especialidades. A partir del año 1985, cuando se recupera la democracia en el país y la autonomía en la Universidad (antes intervenida por el gobierno de facto), se pone en marcha el Programa Docente en Comunidad que retorna al Plan 68 y aglutina proyectos, experiencias y profesionales en espacios comunitarios y servicios de salud del primer nivel de atención. Este ámbito docente y la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria constituyen los primeros escenarios donde se forjó la integración de las especialidades que nos ocupan.

La población

Diversidad

La conciencia sobre la diversidad de la población sujeto de nuestras acciones ha crecido progresivamente y se ha traducido en el lenguaje.

Desde “la salud del niño” pasamos a “la salud de los niños” para expresar mejor con el plural la

¹ Adjetivo en referencia al Informe Flexner (1910) que fundó el modelo de educación médica predominante en Estados Unidos,

caracterizado por la subdivisión y la “departamentalización” del conocimiento (1).

diversidad de formas que puede adoptar la infancia. Luego se introduce la perspectiva de género y se comienza a mencionar explícitamente a las niñas. También se hace explícita la mención a la adolescencia para dar visibilidad a un subgrupo de población que ganó reconocimiento a lo largo del siglo XX, pero que por diferentes motivos mantiene escasa presencia en y para los sistemas de salud.

En Uruguay es reconocido como edad pediátrica el período que va desde el nacimiento hasta los 14 años. La inmensa mayoría de los servicios asistenciales identifican como usuarios de pediatría a los menores de quince años. Gran parte de los sistemas de información del sector salud utilizan los 14 años como edad de corte. Excepción a esto lo constituyen los servicios orientados en forma específica a la adolescencia. En estos casos se abarca toda la franja de 11 a 19 años. Allí la organización suele ser sobre la base de equipos interdisciplinarios diseñados para programas o “espacios adolescentes”.

En el extremo inicial de este período de la vida se ubica el recién nacido² o, incluso antes, el período fetal.

La mirada de este trabajo busca enfocarse en la población y sus necesidades, evitando todo afán taxonómico orientado a fragmentar o repartir lo que ha de ser asumido en forma integral y en equipo. Por ello la población a la que nos referiremos incluye la infancia y la adolescencia en sus concepciones más amplias.³ A efectos de facilitar el uso del lenguaje se utilizará en adelante la expresión niñas/os sin que ello indique la no inclusión de adolescentes.

Complejidad

La variedad que ofrece la edad (y las repercusiones que ello tiene en la organización sanitaria) es solo una parte de la complejidad inherente a la población.

Un aspecto característico de la práctica médica con este grupo poblacional es la multiplicidad del vínculo necesario para establecer el proceso de atención. En la relación sanitaria participa no

solamente el paciente niña/niño o adolescente, sino también al menos un adulto responsable (madre, padre u otro). Esto incrementa los requerimientos para la comunicación efectiva.

El abordaje con enfoque de género es un desafío creciente. Esto requiere el entrenamiento de la mirada a la identificación de necesidades específicas de las adolescentes y niñas, evitar los estereotipos de género, y una actitud de apertura a la diversidad.

La complejidad del objeto viene dada por su carácter social. Se conocen ampliamente –y tal vez aún de modo insuficiente– los efectos que un ambiente adverso produce sobre la infancia y adolescencia. Son etapas especialmente vulnerables a las condiciones físicas, económicas, sociales o afectivas del entorno. La atención verdaderamente integral requiere una mirada amplia, atenta y entrenada que incluya la semiología del contexto. La semiología exclusiva del individuo resulta insuficiente.

Especificidad

No obstante lo diverso, existen aspectos constantes a lo largo de este tiempo vital que justifican su abordaje como unidad. ¿Qué tienen en común las diferentes etapas, circunstancias y personas que se pueden identificar dentro del período definido por la infancia y la adolescencia? Particularmente tres aspectos:

El crecimiento y desarrollo son procesos centrales a lo largo de todo el período, tanto en la vida y la salud de cada persona como de sus familias.

La vulnerabilidad es característica de estas etapas de la vida justamente por las exigencias que imponen los procesos de crecimiento y desarrollo.

La dependencia, que es variable a lo largo del tiempo y según diferentes condiciones. La autonomía pasa de ser nula o muy limitada a ser plena; es durante este período que se incorpora en forma progresiva como atributo de madurez e integración social de la persona. Este hecho constituye en sí mismo un proceso que se debe cuidar también desde la salud.

El potencial que tiene este período en la consolidación de la vida de cada persona como ser vivo y como ser social aumenta la relevancia de la labor profesional que analizamos, trasciende la medicina, alcanza el campo de la responsabilidad social y pública.

² Es importante subrayar esta inclusión ya que en los últimos años ha crecido en Uruguay la participación de la neonatología en la atención de recién nacidos. En algunos casos también para controles ambulatorios. La especialización se ha posicionado como posgrado de la medicina, ya no como subespecialidad de la pediatría.

³ En España se define la Pediatría como “La Medicina integral del período evolutivo de la existencia humana que abarca desde la concepción hasta el fin de la adolescencia” (2).

El primer nivel de atención. Las especialidades

Aunque es posible pensar escenarios diferentes, en Uruguay el primer nivel de atención⁴ es el ámbito natural para la confluencia de la Pediatría y la MFYC. En este nivel el sistema de salud ofrece múltiples y diversos espacios, situaciones y problemas de salud.

La complejidad y diversidad enunciadas permiten intuir el beneficio de la multiplicidad de miradas dentro de un mismo equipo.

El quehacer en el primer nivel de atención se optimiza cuando el trabajo se desarrolla por equipos donde confluyen diversas disciplinas que se interrelacionan a través de sus métodos y sus conceptos, en torno a objetivos y metas comunes. El foco de atención se desplaza desde la disciplina al problema, con lo cual se logra un mejor conocimiento de la realidad y se enriquecen las alternativas terapéuticas.

Los equipos pueden estar constituidos por diferentes números de personas. La Organización Mundial de la Salud define el trabajo en equipo como *“la acción coordinada de dos o más personas, de forma conjunta, simultánea o sucesiva”* (3).

Pediatría y MFYC pueden compartir la labor complementando acciones para brindar atención a niñas/os. Ambas especialidades pueden aportar su conocimiento y visión sobre los problemas de salud e incluso generar conocimiento nuevo a partir del trabajo en conjunto. Cuando profesionales de ambas especialidades intercambian opiniones sobre una situación en particular, una aporta su diagnóstico, el conocimiento del contexto donde ocurre el problema, los aspectos ambientales, culturales y biológicos favorecedores o protectores en relación con este; la otra aporta mayor profundidad en el conocimiento de una patología determinada, sus formas de presentación en las diferentes edades y condiciones. Se generan procesos de intercambio de saberes, de miradas, de enfoques, que trascienden la particularidad; ambas especialidades aprenden y se produce un saber de un nuevo tipo, integrador.

La Pediatría

En Uruguay la Pediatría, desde su creación

como especialidad médica, se desarrolló estrechamente ligada al niño y su familia en el contexto donde vive y se desarrolla. En su concepción inicial fue la especialidad clínica cuya práctica apuntaba a los aspectos vinculados a las patologías propias del niño, pero también a lo inherente a la prevención de enfermedades, a la nutrición y al crecimiento del niño sano.

Es interesante destacar que estos aspectos vinculados a la prevención y promoción de la salud desde la persona sin patologías ostensibles no estaban incorporados a la práctica médica en ese momento, lo que comenzó a mediados del siglo XX y con mayor énfasis luego de la Declaración de Alma-Ata en 1978, donde se definió la atención primaria de salud (APS) como un conjunto de valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios para la organización de servicios de salud y una variedad de criterios para abordar las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud.

La Pediatría como especialidad recibe este legado y lo dinamiza como una manera de abordar la realidad de niñas/os en su entorno familiar y social. El/la pediatra se forma y se “culturiza” como agente social. Esta forma de ejercer la medicina es visualizada también e identificada con beneplácito por la sociedad.

Sin embargo, es necesario decir que esta Pediatría con orientación social, tan profundamente arraigada en nuestro país, no se corresponde con la historia de la especialidad en muchos otros, en los cuales el énfasis está en el campo de la biología y la patología. En varios países de Europa el pediatra es el médico del niño enfermo y habitualmente ejerce su profesión en el segundo o tercer nivel de atención.

La Medicina Familiar y Comunitaria

Más joven que la Pediatría, la Medicina Familiar —denominación⁵ acuñada hace 60 años (4)— se ocupa básicamente del abordaje integral centrado en la persona, sin discriminación de población según patologías, género o edad, pues se define justamente como alternativa a la fragmentación que fue avanzando en la medicina a lo largo del siglo XX (5). Por el contrario,

⁴ La concepción de los sistemas de salud según niveles de atención es un asunto que requiere revisión para dar lugar a formas y modelos más adecuados a las necesidades actuales, no obstante constituye aún una forma de comprensión vigente que adoptaremos para este trabajo.

⁵ Homólogo del general practitioner inglés (bastante más antiguo que 60 años), family physician fue el nombre adoptado en Estados Unidos como recurso para reivindicar el carácter de especialidad que tenía esta práctica (se entendió que general practitioner sugería un

su habilidad principal es agregar, integrar, mirar unido. Es una medicina *sincomial* como la llamara Hugo Dibarboure (6), medicina que reúne, que cuida en unidad (del griego: syn, junto, a la vez; komeo, lugar donde cuidan).

Posteriormente a su “certificado de nacimiento” registrado en Estados Unidos en 1959 con el nombre Medicina Familiar, fue en el mundo iberoamericano que la especialidad encontró su “apellido” y pasó a llamarse Medicina Familiar y Comunitaria. La denominación fue adoptada en numerosos países, entre ellos España, Brasil, Uruguay, Perú. Expresa la vocación territorial de una práctica que tiende a radicarse en servicios de salud próximos a la población, que trasciende los servicios de salud y llega al espacio comunitario, escuelas, clubes, parques, plazas o el domicilio de las personas.

Con variaciones que se pueden observar de un país a otro, comparte con la Pediatría parte del campo de práctica, el enfoque preventivo, el primer nivel de atención y eventualmente la orientación comunitaria. La MFYC se ocupa del cuidado de las personas sanas y también cuando enferman. Profundiza en el manejo clínico de las patologías más frecuentes y en el seguimiento de personas y familias con patologías crónicas. Problemas de naturaleza muy variada en niñas/os y adolescentes pueden motivar la consulta a Pediatría o Medicina Familiar y Comunitaria: seguimiento del crecimiento y desarrollo; prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes de la infancia; dificultades en la escuela o problemas vinculares, entre otros.

Además de la integralidad, esencia de la MFYC, hay otras características que contribuyen a un abordaje desde la totalidad. Totalidad no significa abarcar todo, sino hacerlo en forma unitaria, comprehensiva. Es el ejercicio permanente, es trascender el episodio o asunto puntual que puede motivar la consulta y enfocarse en la persona con su historia y contexto. La característica distintiva de la MFYC es su capacidad de integrar en una mirada la diversidad y pluralidad de problemas que ofrece un individuo, con los elementos del contexto (familiar, comunitario, ambiental, cultural) para desencadenar desde allí el proceso clínico (7).

El especialista en MFYC idealmente trabaja

como parte de un equipo con territorio y población de referencia, lo cual favorece la atención a lo largo del tiempo, en la proximidad de las personas, en contacto con su vida, no solo con sus enfermedades. Esta condición permite, entre otras cosas, el contacto con los procesos mórbidos desde su inicio, cuando aún son indefinidos o incompleta su presentación clínica. La incertidumbre es un insumo frecuente de trabajo.

McWhinney (8) definió los principios de la Medicina Familiar y Comunitaria, entre los cuales destacamos, además del compromiso con la persona y con la comprensión del contexto ya mencionado, la orientación preventiva, el pensamiento epidemiológico (asume el cuidado de personas como parte de una población a la cual busca conocer y comprender), la consideración de los aspectos emocionales y subjetivos en el proceso clínico, la práctica en todos los ámbitos donde transite el paciente y el involucramiento con la gestión.

Entre las herramientas de la MFYC, se destacan la historia clínica basada en problemas, la historia familiar, la visita domiciliaria, el familiograma y otros recursos de abordaje familiar.

La orientación comunitaria, basada en la permanencia en el territorio y el vínculo con las personas y familias a lo largo del tiempo, provee oportunidades para el cuidado de la salud que superan ampliamente las que ofrece el consultorio. Esto, unido a la mirada familiar, los aspectos culturales y ambientales, así como los elementos subjetivos, permiten ese abordaje integral y “unidor” que define a la especialidad y en lo cual radica su potencial.

La Pediatría comparte muchas de estas prácticas, algunos escenarios y algunas herramientas con la MFYC.

La organización asistencial

La organización del sistema de salud tiene una fuerte influencia en los procesos de atención y también en los resultados de salud. Bárbara Starfield ha sido pionera en la producción científica que muestra cómo los sistemas basados en APS logran los mejores resultados en la salud de la población (9–12) regardless of whether the care is characterized by supply of primary care physicians, a relationship with a source of primary care, or the receipt of important features of primary care. The evidence also shows that primary care (in contrast to specialty care).

rango de no especialista) que no por ocuparse de la persona en su totalidad era menos específica en sus conocimientos y herramientas.

El perfil de los profesionales y la organización del trabajo en el primer nivel de atención son componentes clave de la organización sanitaria. Seguí analiza las diferentes alternativas de organización en España e identifica ventajas en la participación de médicos de familia en la atención de la población infantil (7) entre las cuales se destacan:

- ✓ Atención longitudinal.
- ✓ Abordaje biopsicosocial (con conocimiento de la estructura familiar y social del niño/a).
- ✓ Actividades anticipatorias por patologías detectadas en la familia.
- ✓ Mejoría en la competencia clínico-terapéutica de médicos no pediatras para atención a niños.
- ✓ Menor exposición a la sobre intervención sanitaria.
- ✓ Optimización de la labor asistencial del pediatra.
- ✓ Fortalecimiento del lugar del pediatra como referente de otros médicos de cabecera.
- ✓ Mejora en la eficiencia (menores costos directos, indirectos e intangibles) del sistema de salud.

Aunque en muchos países de Europa y occidentales en general se ha extendido una forma de medicina de la infancia que aprovecha estas ventajas e integra médicos de familia en la atención a niños, no ha sido así en España. Como contraparte, lo que ha ocurrido es que “la Pediatría ha ido asumiendo progresivamente, además de las funciones asistenciales del niño enfermo, las de promoción de la salud del niño sano tanto en el ámbito individual (Pediatría preventiva en sentido estricto) como en el comunitario (Pediatría Social)” (13). Siendo así, algunas de las ventajas comparativas atribuidas por Seguí al médico de familia quedarían compensadas siempre que el pediatra asuma protagonismo en el cuidado de la salud (enfoque preventivo), la atención domiciliaria o las actividades comunitarias.

Modelos diferentes se pueden encontrar en otros países. En el Reino Unido y en Australia, la Pediatría no participa en el primer nivel de atención, sino que es una especialidad del segundo y tercer nivel. En Cuba tampoco recibe pacientes directamente, pero participa en el primer nivel en forma programada o a demanda en apoyo a los médicos de familia que hacen la atención en equipo con enfermería, con territorio y pobla-

ción de referencia.

Más allá de los modelos e incluso de los acuerdos entre especialidades, la realidad suele estar pautada por las necesidades y la cultura de población y colectivos profesionales. En España, por ejemplo, aunque lo que en algún momento fue una disputa entre la Pediatría y la MFYC se laudó estableciendo que los niños serían atendidos por pediatras, trajo como consecuencia que la residencia de MFYC no incluya la salud ni las enfermedades de los niños en su currículo. No obstante, según datos actuales de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), el 40% de las consultas pediátricas en España son atendidas por médicos de familia.

Integración en lo comunitario

En el ámbito comunitario las dos especialidades comparten, junto con otros integrantes del equipo de salud, las actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades con grupos y organizaciones de la zona en la que actúan.

Puede ocurrir que las dos especialidades tengan competencias equivalentes o incluso que el pediatra supere al médico de familia en sus habilidades de abordaje comunitario. En algunos países la Medicina Familiar ha desarrollado en forma incompleta este componente. Por lo tanto, corresponde relevar las competencias disponibles en cada equipo en cada territorio concreto. El objetivo es garantizar procesos de soporte social para la salud a través del trabajo en redes y favorecer, por ejemplo, la aproximación comunitaria a los adolescentes o el vínculo con los centros de enseñanza. Lo que resulta claro en este campo es que los límites son difusos e innecesarios y que la complementariedad irá más allá de las dos especialidades en cuestión, para sumar profesionales de diferentes disciplinas y especialidades según los perfiles presentes en el territorio, pero sobre todo incluyendo la participación de la comunidad, único sujeto imprescindible en un proceso comunitario verdadero.

Si existe capacidad de trabajo en equipo y se coloca a la población en el centro de las acciones comunitarias, las competencias se desarrollan y la gestión se innova. Los profesionales aprenden con la gente y con profesionales de otras áreas, se materializa la interdisciplina en escenarios de intersectorialidad.

La formación de los especialistas

La visión holística del personal que asiste niñas/os requiere de una sólida formación humanística centrada en el niño y su entorno familiar. Para todas las especialidades y disciplinas con responsabilidad en la atención a la salud de la infancia-adolescencia en el primer nivel, se han de jerarquizar adecuadamente los aspectos fisiológicos del crecimiento y desarrollo y las patologías prevalentes que representan la gran mayoría de los contactos con el sistema de salud.

El programa de la especialidad de Pediatría ha sido modificado reiteradamente de forma de adaptarlo a las nuevas exigencias de nuestra realidad social. El modelo hospitalario de enseñanza recorre el escenario de la enfermedad, la prevalencia de los accidentes y malformaciones. Las enfermedades hemato-oncológicas y las secuelas de la prematuridad abonan la necesidad de que los recursos en formación tengan contacto en la internación de niños con estas patologías, lo cual en oportunidades desplaza el conocimiento profundo de los aspectos normales intrínsecos de la actividad pediátrica. No deben soslayarse la supervisión del crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes, y el conocimiento del contexto donde estos procesos ocurren.

La construcción del currículo del estudiante de grado y de posgrado para profesionales que asistirán niños (en particular pediatras y médicos de familia) debe incluir la participación de otros actores sociales que actualmente son meros espectadores del proceso formativo: la autoridad sanitaria, los prestadores de salud (estatales y no estatales) y las sociedades científicas de egresados.

El Ministerio de Salud está impulsando en Uruguay la profundización de la APS en los efectos del SNIS una vez que ya se ha consolidado la reforma en la financiación y la gestión. Este marco regulatorio debe contar con agentes de salud que conozcan los objetivos de la reforma y que participen de su desarrollo. El papel de pediatras y MFYC en este camino es de gran trascendencia.

En relación con los prestadores, resulta muy evidente que el mercado laboral está forzando una distribución de médicos y otros agentes de salud hacia áreas y tareas que no se compatibilizan con los principios del Sistema Nacional

Integrado de Salud de promoción de salud, prevención de enfermedades, orientación familiar y comunitaria. De la misma manera que los prestadores contactan con las políticas de Estado para el desarrollo de su cometido esencial de atención a la salud, es importante que se acompañen a las políticas de formación de recursos no solo para participar de estas, sino para dar coherencia a la organización asistencial con las líneas de desarrollo de profesionales en el país.

Las agrupaciones de egresados en cada especialidad cumplen un papel fundamental en el Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC). Esta estrategia constituye un recurso para dar continuidad a la formación de grado y de posgrado. Se pueden desarrollar actividades orientadas a todo el equipo del primer nivel de atención, con estrategias formativas que promuevan la integración y el trabajo en equipo. Resultan aún escasas las actividades de DPMC que convocan a pediatras y MFYC en conjunto. El potencial de crecimiento a este nivel es muy importante en la actualidad.

Como se dijo antes, la formación de especialistas mediante la práctica compartida en la cual residentes de Pediatría y de MFYC trabajan juntos —no solo en el primer nivel de atención, sino también en los servicios de urgencia y emergencia— produce oportunidades y complicidades insustituibles para desarrollar profesionales competentes para el trabajo en equipo. Ese escenario, ideal para la formación de especialistas, puede operar de base y modelo desde la formación de grado y también dar soporte al DPMC.

Organización de la atención y la formación de especialistas en Uruguay

No existe una modalidad única en el país para la atención de la infancia y la adolescencia. El primer nivel de atención del SNIS presenta variaciones aun dentro de un mismo prestador. La Pediatría trabaja en todos los niveles de atención, pero en prestadores estatales no se cubren todos los lugares de trabajo. Inversamente, la MFYC encuentra menor inserción laboral en prestadores no estatales del SNIS (instituciones de asistencia médica colectiva) y seguros privados. Como consecuencia de esta distribución, las oportunidades de trabajo integrado entre las especialidades son escasas. Las que existen predominan en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en dependencias

de la Universidad de la República. Las unidades docente-asistenciales del primer nivel que funcionan desde 2009 son expresión de un Programa de Formación de Recursos Humanos que tiene como “socios” fundamentales a estas dos instituciones. En la actualidad probablemente sea el espacio más propicio para la integración y el intercambio entre Pediatría y MFYC, y particularmente para la formación de sus especialistas.

Cuando el trabajo en conjunto transcurre en un ámbito docente, la integración se ve potenciada por los procesos y los resultados.

La integración durante el proceso formativo de los especialistas ha permitido experimentar y comprender el alcance de esta práctica interprofesional. Se pueden identificar diversos modelos:

- Residentes de Pediatría en rotación en consultorios de Medicina Familiar.
- Residentes de MFYC en rotación en consultorios de Pediatría.
- Ambos residentes rotando juntos en ambos consultorios.

La última opción resulta la más enriquecedora, pues asume como principio que ambas disciplinas tienen algo que aprender y ambas algo que enseñarse mutuamente. Además se potencia en el sentido de que, al mismo tiempo que contribuye a la formación de especialistas, cultiva el respeto y el reconocimiento entre las especialidades.

En la etapa de especialistas consolidados y trabajo en servicios de salud con o sin carácter docente, la integración ha sido incierta y a veces dificultosa. No obstante, también ha sido posible bajo diferentes modalidades en el ámbito clínico y comunitario, con cierto predominio de la modalidad que se describe a continuación:

*El médico de MFYC atiende y sigue longitudinalmente a una familia. Controla el crecimiento y desarrollo de los niños con una visión de integralidad, pues está “viendo” a la familia, sus hábitos, costumbres, su hábitat, etc. Cuando identifica un desvío en el crecimiento o desarrollo, o problemas o patologías que lo ameriten, realizará intercambio con un pediatra que tiene su consulta en la misma zona.

La modalidad para ese intercambio podrá consistir en el envío del paciente a la consulta de Pediatría o bien la presentación de la situación entre especialistas en forma personal o virtual

para ampliar la valoración. La instancia más plena sería un encuentro con presencia de médico de familia, madre/padre/responsable y el niño/niña y pediatra, pero esta modalidad no siempre es posible ni recomendada. Cuando se produce un intercambio participativo, la valoración clínica se enriquece, así como también la familia, que se fortalecerá como protagonista en el cuidado de la salud y aumentará su confianza en los profesionales al identificar el funcionamiento en equipo.

Las mejores formas de coordinación para implementar estos modelos son las que cuentan con la participación de los equipos involucrados. Si la gestión participativa se potencia con la atención organizada sobre la base de problemas y necesidades de usuarios, se obtendrán condiciones óptimas para avanzar a una atención de máxima calidad.

La atención en domicilio puede responder al mismo modelo, aunque esto ha estado fuertemente condicionado por las modalidades de organización del trabajo médico, tipos de cargos y contratos que no siempre incluyen el tiempo y los recursos necesarios para estos procesos.

La situación ideal sería que en cualquier caso la atención en domicilio sea continuidad natural de la atención ambulatoria, por el médico de referencia del niño, sea este pediatra o MFYC. Las condiciones contractuales de pediatras y MFYC en el primer nivel de atención debieran ser equivalentes dado el equivalente nivel profesional de ambas especialidades, y permitir/disponer la atención domiciliar por una y otra.

Una situación más desafortunada se produce cuando la actividad asistencial se realiza fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, por servicios de cobertura parcial. Cuando ello ocurre, la atención se focaliza en la enfermedad, o incluso en el síntoma; se dirige al episodio, disolviendo todo afán de longitudinalidad y los beneficios de este atributo. Ilustran esto los servicios de atención domiciliaria incorporados por las empresas de emergencia móvil. Su desarrollo en las últimas décadas y su persistencia luego de transcurridos diez años de la reforma sanitaria hablan de una necesidad y demanda de la población insuficientemente resuelta por los prestadores integrales del SNIS.

Otro problema que también ha contribuido a distorsionar el avance a una organización óptima de complementación y desarrollo integra-

do es el ofrecimiento de cargos para atención de niñas/os en domicilio a profesionales con formación en MFYC (incluso aún no titulados). Esto constituye claramente un agravio a ambas especialidades: para la Pediatría en el sentido de que un cargo que estuvo diseñado originalmente para pediatras sea ocupado por un especialista no pediatra; para la MFYC en la medida que se ofrece al profesional una práctica recortada, que impide desarrollar la atención longitudinal e integral que forma parte de su esencia e identidad como especialidad.

Los motivos que favorecen este tipo de situaciones son aún materia de análisis. En nuestro país hemos asistido, en las últimas dos décadas, a un verdadero éxodo de los pediatras que se alejan de los espacios comunitarios hacia el segundo y tercer nivel de atención. La encuesta realizada a solicitud de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) en 2010 muestra una realidad muy distinta a lo que sucedía 20 años atrás: solo 1 de cada 5 pediatras cumple funciones parcial o totalmente en el primer nivel, mientras que la gran mayoría trabaja en hospitales o emergencias móviles o desarrollan especialidades pediátricas. Solo el 4 % cumple funciones docentes y prácticamente no existen (con honrosas excepciones) pediatras en áreas rurales. Las razones de esta migración son variadas:

La inclusión laboral para los pediatras jóvenes es más fácil y mejor remunerada en el segundo y tercer nivel y en emergencias móviles.

Los programas curriculares han privilegiado la formación en patologías que requieren el entorno del segundo y tercer nivel para su mejor diagnóstico y tratamiento. A menudo el currículum “oculto” empuja al docente y al estudiante de grado y posgrado a disponer de mayor presencia en los hospitales.

La presencia de las instituciones formadoras de recursos humanos en salud es muy escasa en el primer nivel.

Conflictos y desafíos

A pesar de lo extenso que emerge el campo de trabajo y la inmensidad de desafíos que requieren trabajo colaborativo con diferentes miradas, el encuentro de la Pediatría y la Medicina Familiar y Comunitaria no ha estado libre de dificultades en Uruguay ni en el mundo (2, 14, 15) y se mantiene como asunto de debate actual (16).

Revisar los conflictos identificados en este

campo puede permitir una aproximación a la comprensión del problema.

Un aspecto en común de muchos emergentes es la “disputa” por el paciente. Esto ocurre cuando una de las especialidades, o ambas, reivindican su competencia para la atención de niñas/os sin reconocer la competencia de la otra.

Aunque existe en ambos sentidos, la falta de reconocimiento entre las especialidades es de distinto tipo. Desde la Pediatría suele negarse la suficiente competencia de la MFYC para el cuidado de la salud de la infancia. Desde la MFYC lo que suele cuestionarse es la presencia del pediatra en el ámbito comunitario y los servicios del primer nivel, a veces porque se considera innecesario (se la visualiza como especialidad del segundo y tercer nivel, al estilo inglés), otras veces porque se cuestiona la forma de trabajo que desarrolla la Pediatría, sin garantizar la atención longitudinal de su población, salvo para control periódico programado, esporádico, con ausencia en los períodos de intercontrol, en los cuales acontecen episodios intercurrentes de enfermedad generalmente aguda.

A veces los conflictos se derivan de asuntos prácticos más que de convicciones. Cargos y puestos de trabajo suelen encontrarse en la base de este tipo de problemas. La introducción de médicos de familia para sustituir a pediatras en la atención de niñas, niños y adolescentes es una situación que provoca irritación. Esa circunstancia se torna extrema cuando el especialista en MFYC acepta un puesto que está definido expresamente como cargo de pediatra. Si además ejerce la función por un salario inferior al que se asignaría a un especialista en Pediatría, el problema se profundiza y agrega nuevas facetas.

Esto es diferente a la situación en la cual el médico de familia se incorpora en un cargo de su especialidad para atender a una población de todas las edades y desde ese cargo atiende, entre otros, a niñas, niños y adolescentes. Esta opción resulta legítima, pues aunque es posible tener opinión adversa a ello, responde a un modelo de atención válido.

Otras veces no existe reemplazo de un especialista por otro, pero aun así, la presencia de médicos de familia en ambientes hospitalarios o ambulatorios especializados de pediatría (servicios móviles de emergencia y urgencia) no es bien vista por la pediatría.

En Uruguay estos conflictos han tenido expresiones retóricas más que prácticas. En la cotidianidad predomina ampliamente el trabajo colaborativo ya sea cuando confluyen en territorio los especialistas o cuando necesitan coordinar entre servicios y niveles para asegurar la continuidad de la atención.

En el plano de la retórica hay dos momentos que marcaron el proceso en los últimos veinte años. El primero se ubica en torno a la creación de la residencia de MFYC. El hecho desencadenó movimientos y declaraciones cuestionadoras de la legitimidad de la MFYC como especialidad y de su competencia para atender a la población infantil y adolescente (15, 17). Pero las voces que desautorizaban no procedían del ámbito comunitario. Los especialistas y profesores de Pediatría comprometidos con la práctica comunitaria sostuvieron siempre la apuesta al desarrollo interdisciplinario y multiprofesional de la medicina en el ámbito comunitario y fueron referentes para la formación de los primeros residentes de MFYC (18, 19). La tensión inicial se laudó con el acuerdo de que la formación en Pediatría para los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria estaría a cargo de Pediatría, y así se mantiene hasta el día de hoy.

El segundo momento crítico coincide con los primeros años de funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) instalado a partir de 2008 (20), diez años más tarde del primer momento. Cuando todo hacía suponer que había condiciones para avanzar en la integración, la tensión reapareció. Los hechos nuevos, probablemente subyacentes al nuevo tiempo de tensión, están vinculados a la estructura de trabajo médico en proceso de cambio (nuevos tipos de cargos ofertados, su ubicación geográfica y en el sistema, los estímulos ofrecidos por el SNIS).

En términos prácticos cabe preguntarse cómo se organizan los recursos y la actividad asistencial para promover este trabajo colaborativo. En este sentido, resulta crítico comprender que se requiere un cambio de paradigma en la atención de la salud para que pueda prosperar esta forma de trabajo. Desde una medicina centrada en el vínculo de un paciente con un profesional en un contexto sanitario, mediado por tecnología sanitaria (ya sea un medicamento, una camilla, un otoscopio o una vacuna), el modelo cambia a una medicina centrada en las personas en su

territorio donde equipos de salud interprofesionales se hacen cargo del cuidado de la salud en forma colectiva e interactúan en ámbitos sanitarios y comunitarios en procesos que jerarquizan las “tecnologías blandas” (21) y los abordajes integrales.

Cuando esto ocurre, muchos de los potenciales conflictos se desdibujan. Las zonas de confluencia dejan de ser espacios en disputa cargados con la tensión de marcar límites. Por el contrario, se jerarquizan como oportunidades para el trabajo en equipo. Interesa además señalar que estas zonas no son estáticas. No seríamos consistentes con el paradigma planteado si intentásemos una taxonomía de coincidencias. Porque el contexto planteado no es estático. Por el contrario, se trata de territorios diversos, con personas en permanente cambio que integran familias en movimiento. Los tiempos actuales en los cuales cualquier clasificación de familias resulta insuficiente para abarcar la diversidad existente, cuando los sujetos se encuentran en continuo cambio (de residencia, de carrera, de trabajo, de orientación sexual, de género), resulta más adecuado planear en base a procesos. De ese modo resulta posible identificar situaciones, problemas y necesidades en forma continua, y luego reunir esfuerzos y tareas en torno a las necesidades, acordes a estas.

Necesidades y perspectivas

Pediatría y MFYC comparten la necesidad de mayor profesionalización y reconocimiento del primer nivel de atención dentro del sistema de salud.

Es necesario ampliar y profundizar la formación en y para el primer nivel en el currículo de grado, posgrado y DPMC, y hacerlo mediante actividades que integren a pediatras y MFYC. Algunos problemas complejos que demandan atención frecuente en el primer nivel pueden ser buenas guías para el desarrollo de estrategias de formación e investigación integradoras entre Pediatría, MFYC y otras disciplinas o especialidades. Algunos ejemplos posibles: déficit de atención y aprendizaje, adolescencia, orientación familiar, aproximación a la genética en el primer nivel de atención, obesidad infantil, violencia, acoso, entre otros.

La jerarquización del primer nivel no es completa si lo académico no se acompaña de una estructura laboral y salarial que refleje su impor-

tancia. En capítulos previos fueron presentados diversos problemas que ilustran de qué forma la organización del trabajo subyace a varios de los problemas actuales. La revisión de cargos y salarios que tienda a la adecuada ponderación de la Pediatría y la MFYC en el primer nivel, ha de incluir la revisión de la organización del trabajo para promover modelos que favorezcan la colaboración.

Existen otros desafíos para lo formativo, entre ellos:

- ✓ Ampliar los escenarios de aprendizaje: incorporar más instituciones no estatales y ampliar la red de servicios docentes en todo el país con mayor presencia en el interior.
- ✓ Ampliar las oportunidades de cooperación internacional y estimular pasantías e intercambios de estudiantes de grado, posgrado y docentes.
- ✓ Mejorar la oferta de herramientas educativas e inclusión de TICs.
- ✓ Ampliar el currículo con competencias innovadoras características de los problemas del siglo XXI y su forma de presentación en nuestro país y nuestra región.
- ✓ Insistir en la autoformación y la autoevaluación.

¿Cómo afrontar los conflictos y construir un futuro que tenga en su centro a niños, niñas y adolescentes con sus familias para mejorar su salud? He aquí nuestro objetivo, lejos de ser la lucha por la prevalencia de una especialidad sobre la otra.

Durante un encuentro realizado en el Sindicato Médico del Uruguay en el año 2013, convocado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, se identificó la necesidad de incrementar el número de especialistas en ambas áreas, así como también mejorar la distribución a nivel nacional y a nivel de los diferentes efectores del SNIS.

En el ámbito universitario ambas especialidades se han caracterizado por un alto compromiso e involucramiento en la formación de estudiantes de grado en la Facultad de Medicina, Universidad de la República, así como por su actividad docente en el ámbito comunitario.

Pediatría cuenta con tres clínicas pediátricas (A, B y C) ubicadas en el Hospital Pediátrico, Centro Hospitalario Pereira Rossell y un departamento de Pediatría. Medicina Familiar y Comunitaria

cuenta con un departamento y quince unidades docente-asistenciales (UDA) ubicadas en el primer nivel de atención, en distintos puntos del país (4 en Montevideo, 3 en Canelones, 2 en Florida, 1 en Maldonado, 1 en San José, 1 en Colonia, 1 en Paysandú, 1 en Salto, 1 en Tacuarembó).

Docentes de Pediatría participan de las UDA dependientes de Medicina Familiar y Comunitaria. El mayor grado de integración entre las especialidades bajo esta modalidad lo alcanza la UDA Canelones al Este, donde se trabajó en forma coordinada desde los departamentos de Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria en interacción con actores del territorio (efectores del SNIS públicos y privados, hospital local, Banco de Previsión Social, municipios), logrando instalar un programa de desarrollo de la Pediatría en territorio con componentes de enseñanza de grado y posgrado, actividad asistencial, extensión universitaria e investigación, ensamblado con los procesos que se desarrollaban en el mismo territorio por Medicina Familiar y Comunitaria.

En el marco de este proceso, se concretaron acciones tan relevantes como la integración de docentes de Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria al hospital local, fortaleciendo así la capacidad y respaldo. En coincidencia con esto el hospital avanzó en la apertura de camas para internación breve de lactantes y niños. Se realizó una capacitación a los equipos en las competencias necesarias para asegurar el acceso a la mejor tecnología en oxigenoterapia, se instaló consulta periódica de especialidades pediátricas en el hospital local, y se regularizaron actividades académicas de Pediatría para pregrado y posgrado, todo en conjunto con Medicina Familiar y Comunitaria. Este fortalecimiento permitió habilitar la UDA Canelones al Este como espacio para la formación de posgrados de Pediatría desde el año 2017.

Frente a este escenario de avance, existen aún muchos pendientes. La reorganización de la estructura académica de Pediatría en la Facultad de Medicina, colocando parte de sus equipos docentes en el primer nivel, hoy concentrados en el hospital, es un asunto para el cual existen propuestas y que está en consideración. La revisión de la estructura del trabajo médico en el primer nivel y el avance a un diseño que defina territorios y equipos donde se integren pediatras y médicos de Familia y Comunidad,

con condiciones contractuales y remunerativas equitativas, es un paso inicial que podrá abrir posibilidades para mayor innovación en función de las necesidades de la población.

A lo largo de los años, que ya se pueden contar en décadas, lo único que ha mostrado valor es el hacer. Lo que va quedando, lo que hoy es tangible, es producto de lo que muchas y muchos pediatras y médicos de Familia y Comunidad, y médicos de otras especialidades, y profesionales de otras disciplinas, y la gente, han alcanzado con su trabajo cotidiano que no se detuvo al oír voces de querrela o desconfianza.

En una perspectiva de futuro, es importante subrayar las coincidencias en asuntos estratégicos: el contacto con lo social que forma parte de la Pediatría —y esto es particularmente fuerte en la Pediatría uruguaya—, así como de la Medicina Familiar y Comunitaria (5), es una definición más que disciplinaria. Abarca el campo epistemológico, ético y político y traduce una concepción de la medicina comprometida con los procesos de determinación social de la salud. Esto constituye una piedra angular esencial sobre la cual se puede fundar un proyecto de desarrollo integrado para mejor salud de niños/as, para mejores especialistas y mejor sistema de salud.

Referencias bibliográficas

1. Borrell RM. La educación médica en América Latina: debates centrales sobre los paradigmas científicos y epistemológicos. En: Universidad Nacional de Rosario, editor. Proceso de transformación curricular: otro paradigma es posible. Rosario: UNR Editora; 2005.
2. Malmierca Sánchez F. Quién debe atender a los niños: la opinión del pediatra. SEMERGEN - Medicina de Familia. Noviembre de 2006;32(9):444-8.
3. WHO Study Group on Multiprofessional Education of Health Personnel: the Team Approach. Aprender juntos a trabajar juntos por la salud: informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación Multiprofesional del Personal de Salud, el Criterio de Equipo [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1988 [citado 10 de marzo de 2019]. 82 p. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/41234>
4. Rakel M. Textbook of Family Practice. 3a. Toronto: WB. Saunders; 1984.
5. Spann SJ. La medicina familiar: Definición, historia, principios y futuro. En: Introducción a la Medicina Familiar. Montevideo: Universidad de la República; 1998. p. 21-38.
6. Dibarboure H, Macedo JC. Introducción a la Medicina Familiar. Montevideo: Universidad de la República; 1998. 550 p.

7. Ponzo J. La integralidad y la continuidad son las herramientas más poderosas que tiene la medicina Familiar. Homenaje de Richard Roberts a Bárbara Starfield. [Internet]. Sumefac. 2012 [citado 24 de febrero de 2019]. Disponible en: <http://sumefac.com/2012/06/10/barbara-starfieldhomenaje-del-presidente-de-wonca/>
8. McWhinney IR. Medicina de familia. Barcelona: Mosby/Doyma libros; 1996.
9. Starfield B. Primary Care and Health. A cross national comparison. JAMA. 23 de octubre de 1991;266(16):2268-71.
10. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. The Milbank Quarterly. 2005;83(3):457-502.
11. Starfield B. Refocusing the System. N Engl J Med. 2008;359(20):2087, 2091.
12. Starfield B. Access, primary care, and the medical home. Rights of passage. Medical Care. 2008;46(10):1015-6.
13. Asociación Española de Pediatría. Libro blanco de las especialidades pediátricas. Madrid: Exlibris S.L.; 2011. 255 p.
14. Seguí Díaz M. Quién debe atender a los niños: la opinión del médico de familia. SEMERGEN - Medicina de Familia. Octubre de 2006;32(8):390-8.
15. Comité de Pediatría Social y Atención Primaria de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El rol del pediatra en el primer nivel de atención. Boletín de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. 2003;11(1):2.
16. Díaz MS. Quid pro quo: Los médicos de familia en consultas de pediatría [Internet]. Quid pro quo. 2018 [citado 24 de febrero de 2019]. Disponible en: <http://borinot-mseguid.blogspot.com/2018/05/los-medicos-de-familia-en-consultas-de.html>
17. Martínez AM. Atención primaria de la salud y mortalidad infantil. Los grandes derechos de los más pequeños [Internet]. Ser Médico. 1996 [citado 24 de febrero de 2019]. Disponible en: <https://www.smu.org.uy/publicaciones/noticias/noticias96/art17.htm#main>
18. Pais T. Pediatras y Médicos de Familia ¿Antagonismo o complementación? Boletín de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. 2003;11(1):5-6.
19. Canetti A, Da Luz S. Enseñanza universitaria en el ámbito comunitario. Desafíos y propuestas para la formación de recursos en el área de la salud. Montevideo: Edición de autoras; 2003. 219 p.
20. Ley 18.211. Sistema Nacional Integrado de Salud. Normativa referente a su creación, funcionamiento y financiación. [Internet]. 2007 [citado 18 de agosto de 2016]. Disponible en: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5504426.htm>
21. Merhy EE. Salud: cartografía del trabajo vivo. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2006.

*Dra. Jacqueline Ponzo

Médica de Familia y Comunitaria.

Prof. Adjunta de Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad de la República.

Ex Presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria.

Presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (2018-2020).

**Dr. Walter Pérez

Pediatra.

Profesor Director Clínica Pediátrica B, Facultad de Medicina, Universidad de la República.

Ex Presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

Ex Presidente de la Asociación de Docentes de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de la República.

LOS PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE EN EL PARTIDO DE LA PLATA. DISCUSIONES A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ENFOQUE DE GÉNERO.



PROF. DRA. SUSANA ORTALE*

Sumario

Este trabajo, enmarcado dentro de proyectos más abarcativos iniciados en el 2007, forma parte de una línea específica de indagación cuyo objetivo es analizar el contenido de los programas de salud sexual y reproductiva vigentes en el partido de La Plata y contrastarlo con las percepciones y experiencias de maternidad de madres adolescentes pobres, grupo cuya vulnerabilidad deriva de la condensación de inequidades socioeconómicas, de género y de edad.

Introducción

Sabemos que las categorías género y edad, en tanto construcciones culturales que aluden a relaciones básicas de desigualdad -atravesadas por estructuras económico-políticas particulares-, están cargadas de significados que se dirimen en un campo social predispuesto a reforzar relaciones de dominación.

En él, se registra una mirada hegemónica que estigmatiza la maternidad en la adolescencia, fenómeno que viene siendo objeto de interés y preocupación por parte del sector sanitario. La maternidad adolescente se construye como problema pero no lo es per se ni puede ser abstraída de contextos específicos.

Los discursos predominantes sobre el tema tienen por finalidad controlar la sexualidad -sobre todo femenina- y la reproducción en función de

necesidades políticas y económicas. Desde hace unas décadas el énfasis está puesto en el riesgo que representa para la díada madre/hijo -activado por conductas “inmaduras”, “irresponsables” e “irreflexivas”- y en el aporte de la maternidad/paternidad adolescente en la reproducción de la pobreza.

Más allá del riesgo que entrañaría la adolescencia para el embarazo, el parto y la salud infantil, la exploración de la maternidad desde la perspectiva de las propias adolescentes, del significado que asume para ellas y de los problemas sentidos que se vinculan con su estatus de madre, no han tenido la atención que amerita. El interés no se ha desplazado a indagar qué tipo de situaciones y experiencias concretas rodean la maternidad de adolescentes pobres, sus razones y problemas, cuál es su particularidad, cuáles son las necesidades sentidas, cuáles las respuestas por parte del estado; preguntas que constituyen, entre otras, el núcleo de este estudio.

El trabajo representa un ejercicio inicial que pretende identificar -bajo el foco de la perspectiva de género y de derechos, perspectivas que la retórica de las políticas siguen[2]-, la interpretación y el abordaje presente en las políticas sociales con relación a los problemas de la salud sexual y reproductiva, dimensión atravesada por valores culturales, experiencias, racionalidades y moralidades en disputa particularmente en el caso de la adolescencia.

Ubicado pues en la problemática general del reconocimiento de derechos, el recorte contrasta el marco jurídico y normativo con el significado que asume la maternidad en las adolescentes pobres y plantea reflexiones en torno a la tensión universalidad/particularidad, igualdad/diferencia, redistribución/reconocimiento presente en los programas de salud sexual y reproductiva que las tienen como destinatarias.

Antecedentes en la temática y consideraciones preliminares

El estudio de las desigualdades de clase, género y étnicas ha contribuido a reconocer la heterogeneidad de situaciones y relaciones presentes en la categoría “adolescencia”, reconocimiento que sin embargo no ha logrado incidir en el modelo de adolescencia homogéneo presente en las instituciones, permaneciendo dicha categoría soslayada del arquetipo de maternidad/paternidad predominante en nuestra sociedad desde hace poco más de 50 años. En el mismo sentido, la desnaturalización del género ha sido promovida tempranamente desde la antropología por Margaret Mead (1928) propuesta que ha sido revitalizada desde distintas perspectivas académicas y posiciones políticas. Por otra parte, sabemos que la sexualidad y la reproducción son prácticas que han sido objeto de normatización creciente desde el campo de la salud (Foucault, 1980) cuyos objetivos no siempre explicitados se han incorporado a las agendas en función de necesidades definidas históricamente (Cardacci, 2006).

“El problema” de la maternidad adolescente, construido por los adultos y por las instituciones aparece en nuestro país como preocupación de la salud pública en 1960, habiéndose edificado sobre tres campos fundamentales: el moral, el legal y el de la salud (Palomar Vereá, 2004) a partir de los cuales los adolescentes son controlados, normalizados o estigmatizados. Tal como plantea Ariel Adaszko (2005), la maternidad adolescente sigue ligada a un discurso victimizador, homogeneizador y alarmista, ubicando al evento en un lugar negativo e inaugurando una trayectoria de infortunios.

Debemos advertir que la exploración efectuada sobre el campo de la salud sexual adolescente en términos generales refiere a sectores pobres (Gogna 2002, 2005; Adaszko, 2005;

Pantelides 2004, 2005; Climent y Arias, 2000, Marcús, 2006) y que los riesgos para la salud materno-infantil se han sobredimensionado, especialmente en el caso de las madres de 18 y 19 años, que concentran la mayor proporción dentro del conjunto (UNICEF/INDEC, 2003; Adaszko, 2005). Cabe destacar que tales riesgos se derivan de la condición social y no de la edad. Tal como plantean algunos autores, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad ante determinadas presiones y situaciones de riesgo, entendiendo a la vulnerabilidad como la “exposición ante la falta de información y/o acceso a los recursos necesarios para poner en práctica la información de la que se dispone, sea esto por factores socioeconómicos o culturales como las relaciones de género.” (Pecheny, 2000: 418).

Desde el punto de vista sanitario, las desigualdades de género en la vida reproductiva se traducen en algunas tendencias epidemiológicas (cambios en la tasa de infección por HIV según género, incremento del embarazo adolescente temprano, consecuencias de abortos inseguros) que afectan especialmente a las adolescentes pobres[3]. Pero además, ellas también se traducen, articuladas con la situación de clase, étnica, etárea, en valores, prácticas y proyectos de vida que naturalizan desiguales posibilidades de elección en otros aspectos de la vida. Tener la posibilidad de tomar decisiones, acceder y controlar recursos, es central para el empoderamiento de las mujeres y sabemos que más marcadamente que en otros, en el espacio de la sexualidad y la reproducción, las mujeres aún se encuentran subordinadas.

En tal sentido, el marco de los derechos humanos puede dar visibilidad a la vulnerabilidad de ciertos grupos a la salud y/o violaciones de derechos no reconocibles con los instrumentos conceptuales propios de la tradición médico-sanitaria (Paiva, 2000). En nuestro país, distintos investigadores (Faur y Gherardi, 2005; Checa, 2005; CELS, 2005; Petracci y Ramos, 2006; Schuster y García Jurado, 2006) han señalado que históricamente, las mujeres argentinas han visto afectado su derecho a decidir libre y responsablemente si tener o no hijos, cuántos, cuándo y cómo tenerlos, y a pesar de la adhesión a la CEDAW[4], a la de otros instrumentos internacionales de derechos humanos y al monitoreo realizado por el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CON-

DERS)[5], la situación persiste. Las dificultades en el acceso a la información y a los recursos anticonceptivos son especialmente marcadas en las mujeres más pobres y más jóvenes, con consecuencias en los embarazos no buscados y los abortos inducidos (Gogna, 2003).

Los grandes aportes realizados por Gogna en “El Estado del Arte” (2005), nos muestran cómo, en toda América Latina, los estudios realizados durante los noventa, marcaron una tendencia similar en la región en la que se devela que: “... un alto porcentaje de adolescentes de ambos sexos tienen una vida sexual activa, no tienen suficiente información acerca de la sexualidad, anticoncepción y reproducción, presentando también dificultades para tomar medidas preventivas en materia de ETS y VIH-SIDA, así como en el caso de embarazos no deseados”. (Maddaleno, cit. por Gogna, 2005).

Pero, más allá de los instrumentos jurídicos y de su contemplación por parte de las políticas sociales, es necesario aprehender cuanto del acceso a derechos se dirime en espacios definidos como privados -tal el caso de las familias y las parejas-, estructurados bajo la misma lógica de desigualdad en las relaciones, y tal vez con más fuerza, que en el resto de las instituciones sociales.

Igualdad, diferencia, desigualdad...¿por qué mirar los derechos?

“El aprendizaje del y acerca del otro está motivado por el convencimiento de que esa persona (otra) es uno de los nuestros/as” (Martha Nussbaum, 1992. cit. por Susana Moller Okin, 1996).

La posición de la que se parte pretende integrar en el análisis de las políticas sociales dirigidas a atender la problemática de la maternidad adolescente, las nociones de igualdad de género y edad. La noción de igualdad no es escindible de la idea de justicia y del goce de derechos, igualdad que lejos de estar dada, se tiene que construir. Siguiendo a Amorós (2000), la igualdad supone equiparar diferencias bajo un mismo parámetro, homologar derechos entre partes discernibles y condenar a las jerarquías o desigualdades que se deriven de diferencias de cualquier tipo.

Así, las preguntas que subyacen son las que indagan la tensión entre la universalidad (concreción de la igualdad) y la particularidad (el reconocimiento de la diferencia) y en qué medida la interpretación de las diferencias y de las

desigualdades afecta el logro de la igualdad. La concreción de la justicia como objetivo general de las políticas sociales requiere lidiar con esta tensión: la particularidad no se disuelve en la universalidad, sino que ésta última debe sostener las diferencias de un modo no jerárquico.

De cara a un relativismo radical o a un particularismo extremo, el marco de los derechos humanos -con sus principios de universalidad y no discriminación- posibilita sostener la igualdad y el logro de justicia a través de demandas de reconocimiento (por parte de grupos con identidades culturales subordinadas) y de redistribución (por la injusticia económica). La base de la desigualdad remite a la imposibilidad de lograr derechos sociales[6], los que no son de aplicación automática y ponen en tensión conflictos distributivos y de reconocimiento (Fraser, 1997): ¿cómo formular políticas que los atiendan simultáneamente?

La perspectiva de derechos en las políticas sociales supone poner el foco en las obligaciones del Estado: respetar, proteger y satisfacer, incluyendo claro está, el acceso a los mecanismos de exigibilidad a todos los ciudadanos. Los derechos no modifican la realidad, las luchas lo hacen, en todo caso ellos habilitan para la lucha; tal como sostiene Birgin (2003), ejercer derechos constituye una práctica discursiva social y específica que expresa niveles de acuerdos y de conflictos.

Las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por los países implican que éstos deben adecuar sus marcos jurídicos con vistas a garantizarlos, debiendo desarrollar políticas adecuadas y mecanismos necesarios para ponerlos en práctica. Asimismo, en tanto las normas no se siguen forzosamente de transformaciones institucionales, también se compromete a toda la sociedad, no sólo al Estado, a participar en su cumplimiento.

Dentro del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, sustentados en el respeto de los derechos humanos universales y de las garantías constitucionales, “reconocen la facultad de las personas de tomar decisiones libres acerca de su vida sexual y su capacidad reproductiva. Suponen el ejercicio y la orientación de la sexualidad libre de discriminación, coacción o violencia así como el acceso a la información sobre el cuerpo, la educación y la salud sexual. El ejercicio de los mismos implica la posibilidad y

capacidad de decisión respecto de tener hijos en condiciones que hagan posible elecciones libres y seguras” (Defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, s/f).

Sabemos que las mujeres tienen desventajas tanto en términos de redistribución como de reconocimiento, que la pobreza afecta cuantitativamente más a mujeres y niños/adolescentes, que la situación de las mujeres pobres no es cualitativamente diferente del resto de las mujeres ricas: es similar aunque peor (Moller Okin, 1996:191) y que el modelo que sigue operando con fuerza vincula los derechos sociales a los laborales (pese a estar positivizados) y por tanto las mujeres acceden a ellos como dependiente del varón (Guzmán, 2001). Tal como señala Joan Scott “el género es el campo primario en el cual o por medio del cual se articula el poder y actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas (1997: 64). (...) “las relaciones de género están entrelazadas en el contexto más amplio de la división de los recursos y las responsabilidades, exigencias y obligaciones entre diferentes grupos sociales de mujeres y hombres en cualquier sociedad determinada. La conciencia de género en las políticas y en la planificación exige un análisis previo de las relaciones sociales de producción dentro de las instituciones pertinentes de familia, mercado, Estado y comunidad” (Kabeer, 1994: 289).

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1981) se establece que los países adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en la atención médica, garantizar su acceso igualitario a los servicios de salud, incluyendo los de planificación familiar, servicios apropiados para la atención del embarazo y parto y posparto y asegurar nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, información, asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar, decidir el número de hijos e intervalo de nacimientos, acceso a información y medios que les permitan acceder a esos derechos.

En el campo de la salud sexual y reproductiva, el reconocimiento de los derechos de los adolescentes se ha ido materializando a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN, 1989 -especialmente art. 24-), de la Conferencia de Viena (la salud es un derecho humano básico, 1993), del Plan de Acción

de El Cairo (1994) y de la plataforma de Beijing (1995). En ella se conceptualiza a la salud sexual y reproductiva en el marco de la equidad y de los derechos humanos, garantizando la promoción de la salud sexual y reproductiva de mujeres y varones y el ejercicio de una sexualidad y reproducción saludables, libres y seguras. Aquí, es donde los adolescentes quedan claramente definidos como sujetos destinatarios de acciones públicas dirigidas a la promoción y defensa de sus derechos reproductivos. Más adelante se hará visible el vacío legislativo sobre planificación familiar y la falta de compromiso de la Argentina durante años con relación a este derecho.

La Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, sustentada en la CIDN, representa un cambio cualitativo en la consideración de dichos grupos: dejan de ser objeto de intervención, compasión o represión por parte de la familia, la sociedad y el estado y pasan a ser sujetos pleno de derecho, merecedores de respeto, dignidad y libertad, derecho que plantea dificultades para eludir miradas y prácticas no esencialistas.

En tal sentido, cabe destacar que la patria potestad de los padres[7] no puede actuar obstaculizando la educación sexual de los hijos ni la atención en los servicios de salud; en tanto derechos, la patria potestad debe garantizar su ejercicio.

Sucede que por lo general, en este caso, “sus derechos son traducidos negativamente, en términos de protección, de un modo en que se deslizan los aspectos morales relativos al control social y a la suspensión de las posibilidades de auto-representación en virtud de un juicio moral” (Llobet, 2006:8). Dicha autora advierte, citando a Laclau (1996), que los representados están ausentes del sitio en que la representación tiene lugar, teniendo el representante un papel de cierre, constitutivo de la identidad del representado.

Finalmente, regresando al derecho a la salud sexual y reproductiva, las obligaciones del Estado que deben ser contempladas incluyen: disponibilidad, accesibilidad (física, económica, información, no discriminación), aceptabilidad y calidad de los servicios a las que se suman el acceso a la información y a los canales de interpelación.

Metodología

Se trata de un diseño cualitativo basado en el análisis de fuentes secundarias y primarias. Las primeras comprenden las leyes nacionales y provinciales relacionadas con la salud sexual y reproductiva destacándose las siguientes: Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva[8] (N° 25.763), el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ministerio de Salud, 2003), la Ley provincial 13.066 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y de los documentos sobre programas provinciales y municipales vigentes en el municipio de La Plata. Entre ellos se destacan el Programa de Salud Materno-Infantil del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los Programas de Salud Reproductiva y de Prevención y Educación Sexual dependientes de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata[9]. Cabe señalar que las acciones desarrolladas en el municipio de La Plata, se enmarcan en las normativas provinciales.

El análisis apuntó a identificar sus características (fundamentos, objetivos, actividades, cobertura, destinatarios) vis a vis al enfoque de derechos y de género y la adecuación de los programas al marco legislativo a fin de encontrar la construcción y las interpretaciones sobre la maternidad adolescente realizada por el campo jurídico y por el sector salud. Dicha información se contrasta con la relevada mediante entrevistas realizadas a veinte mujeres adolescentes (o que lo fueron recientemente), residentes en seis barrios pobres del municipio de La Plata[10]. En ellas se profundizaron aspectos vinculados con las valoraciones, expectativas y significados que rodean a la maternidad, los cuidados reproductivos, su apreciación sobre la mirada de los adultos a la condición de madre, la participación de sus parejas u otros actores en las tareas reproductivas, el conocimiento de sus derechos a la salud sexual y reproductiva y el acceso y evaluación de los servicios de salud y de otros programas sociales que las incluyen como destinatarias.

En síntesis: en el análisis de los programas se explora la incorporación del enfoque de género y la interpretación política de los problemas de sexualidad/reproducción de las adolescentes en el marco de los derechos humanos y en el de los discursos de las entrevistadas, se indaga su interpelación.

El abordaje antropológico, centrado en la recuperación de la perspectiva de los actores, “ese universo de referencia compartido -no siempre verbalizado- que subyace y articula el conjunto de prácticas, nociones y sentidos organizados para la interpretación y actividad de los sujetos sociales” (Guber, 1991:75) sigue el principio que indica su necesaria contextualización. El recaudo de no absolutizar el punto de vista de los actores ni abstraerlo de condiciones y posiciones determinadas estructuralmente, se basa en asumir que la estructura social y de significado refieren a condiciones de desigualdad y diferencia que se expresan en las relaciones construidas entre los actores (Menéndez, 1997) .

En esto se incluye la posición de quien investiga, la que en este caso parte de la valoración de la igualdad en los términos arriba mencionados a partir del cuestionamiento de las articulaciones en términos de desigualdad y diferencias de poder. En tal sentido, la doble hermenéutica contiene la interpretación que el investigador hace acerca del sentido que el actor da a lo que dice y hace.

El campo normativo y las políticas: leyes y programas

El marco en el que se inscribe la problemática objeto de estudio es el del derecho a la salud. Desde hace poco tiempo existe legislación nacional y provincial, así como planes y programas de distintos niveles gubernamentales y no gubernamentales.

En Octubre de 2002, se sanciona la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva[11] (N° 25.763), luego de una larga historia de conflictos entre actores de la sociedad civil y de 7 años de vaivenes parlamentarios. Para los sectores conservadores y eclesiásticos representó una estocada y para el movimiento de mujeres, un logro que no cubrió todas las expectativas (Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales[12]).

Ella tiene por objetivos: disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil, prevenir/disminuir abortos, promover la salud sexual y reproductiva, prevenir y tratar enfermedades de transmisión sexual, de cáncer genito-mamario, prevenir embarazos no deseados, brindar educación sexual a los adolescentes. Se reconoce el derecho de todos a acceder a métodos anticonceptivos de su elección reversibles, seguros, eficaces y

aceptables y de recibir atención y adoptar decisiones sin discriminación, coacción o violencia alguna. Pero su reglamentación en el 2003, creando el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, restringió la aplicación de la ley. Los objetivos de ésta benefician a toda la población, sin diferenciación de ningún tipo pero la reglamentación en el caso de los niños[13], adolescentes e incapaces, recomienda la presencia de un adulto responsable, especialmente en los menores de 14 años. Esta indicación fragiliza la atención en el “interés superior del niño”[14] consagrado constitucionalmente, según el cual debería prevalecer su voluntad (en tanto, por ej. podría sentirse cohibido frente a sus padres/tutores). Además, se obliga sólo a las escuelas públicas a implementar programas de educación sexual, las que representan la mitad de establecimientos educativos del país[15]. Quienes asistiesen a escuelas privadas (confesionales o no) verían afectado su derecho a la información, también garantizado constitucionalmente. Otra restricción se vincula con la posibilidad de que servicios públicos de salud o profesionales particulares se exceptúen de suministrar métodos anticonceptivos, excepción contemplada en la ley para los servicios privados confesionales. Y esto atenta contra el acceso irrestricto a la planificación familiar (Shuster y García Jurado, 2006).

En la provincia de Buenos Aires, se reglamenta en el 2003 la Ley 13.066, con similares objetivos a la ley nacional, creando el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Cabe destacar que el gobernador de turno vetó la ley provincial derogando el artículo que disponía su cumplimiento en todas las escuelas, por considerar que contrariaba la libertad de culto, pues obligaba a los establecimientos privados (confesionales o no) y no respetaba las convicciones personales. Esto reflejó las presiones de sectores conservadores y religiosos, preocupados por proteger el derecho de los padres a dar la educación que consideran adecuada y por eximir a los establecimientos privados de la regulación legal. Las escuelas privadas -la mayoría subsidiadas por el Estado- podían no impartir esa educación, afectándose el derecho a la información de niñas y niños. En la ley aprobada se manifiesta como objetivo “valorar la maternidad y la familia”, considerada ésta como una sociedad

natural existente antes que el propio Estado.

La provisión de anticonceptivos para menores de 14 años está ligada a la firma del consentimiento informado de los padres. Asimismo, el Programa provincial posibilita exceptuarse de participar en los programas de salud reproductiva a aquellos profesionales que aduzcan objeción de conciencia.

En el ámbito provincial dicho programa quedó incluido como un sub-programa de Salud Sexual y Reproductiva dentro del Programa Materno Infantil. Este último tiene como propósito “contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias bonaerenses, promoviendo el cumplimiento del derecho a la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes en sus comunidades”. El programa provee de manera gratuita insumos (leche, medicamentos, instrumental), la libreta sanitaria y material de difusión y busca mejorar el acceso y la calidad de la atención a la salud, la niñez y la adolescencia, promover estilos de vida saludables en la población y disminuir las tasas de mortalidad de la población materno infanto juvenil[16].

Si bien el subprograma explicita que la salud reproductiva se basa en la promoción en varones y mujeres del desarrollo de una sexualidad sana, placentera y sin riesgos a lo largo de todas las etapas de su vida, es claro su énfasis en la procreación responsable[17].

Tal como aparece en el documento, la Procreación Responsable es un derecho cuyo ejercicio permite: elegir el número de hijos que cada pareja desea tener; respetar el intervalo óptimo entre un hijo y otro; disminuir la mortalidad materna, entre otras causas, por abortos provocados, o embarazos en edades muy tempranas o tardías; evitar los embarazos no deseados. Supone también tomar decisiones luego de haber recibido información sobre los métodos anticonceptivos disponibles, respetando convicciones y deseos de las personas. El subprograma se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: información, consejería, entrega gratuita de insumos (preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, anticoncepción hormonal de emergencia, DIU, folletería y manuales para agentes sanitarios), y control de salud (exámenes periódicos de salud para la mujer. PAP, serología en ETS, examen de mamas, controles ginecológicos).

Según un informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires[18] (Chiara, 2003:15)

“La tasa de mortalidad materna pone en evidencia la existencia de deficiencias en el proceso de atención de la embarazada (captación precoz, calidad de los controles prenatales), en la calidad de la atención del parto y el puerperio y en la planificación de la fertilidad. Evidencia también la falta de respuesta ante situaciones de emergencia asistencial, tales como hemorragias, infecciones y complicaciones de la hipertensión arterial. “El embarazo adolescente representa un 23% de las consultas ambulatorias en los servicios públicos de salud[19]. (...) Sin embargo a pesar del contacto estrecho que se genera entre las adolescentes y los equipos de salud en ocasión del control prenatal, la tasa de siguientes embarazos continúa siendo alta en la Provincia[20], [21].”

Según datos de una encuesta citados en dicho informe, “el 49% de las adolescentes sexualmente activas que han estado embarazadas no utilizan anticonceptivos, cifra que alcanza a 61% en adolescentes sin antecedente de embarazo previo. En la Provincia de Buenos Aires, las tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, después del crecimiento significativo de las tres últimas décadas se han mantenido constantes a partir de 1991, a lo que se suma el incremento resultante de los embarazos en madres menores de 15 años” (Chiara, 2003:15).

Es importante señalar que diez años después de los datos referenciados en ese informe, pese a la aprobación de la Ley y a la vigencia del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a fines de 2006 el (sub)-programa incluía a un 25 % de menores de 20 años y estaba representada por un 98 % de mujeres[22].

En el municipio de La Plata, de acuerdo a un informe de gestión del 2001 de la Secretaría de Salud[23], el perfil prestacional de los centros de salud municipales revela que el 65% de las prestaciones se dirigen a la atención del binomio madre-hijo: el 88% de ellas corresponden a pediatría, 10% a control de embarazo y 2% a consultas ginecológicas. La cobertura de mujeres embarazadas bajo control en dicho año (3.171 embarazadas) incluye al 65% de las embarazadas previstas (en función de la población y la tasa de natalidad en las áreas programáticas). Para el 2003 se proponen como metas alcanzar una cobertura de control de embarazos desde el primer trimestre superior al 80% en la población objetivo y capacitar 600 instructores “para

la educación sexual formal y humanizada”.

El Programa de Salud Reproductiva está destinado a promover la procreación responsable y la planificación familiar siendo sus objetivos: prevenir factores de riesgo físico-psíquico y social; promocionar actitudes sexuales saludables mediante acciones educativas, prevenir embarazos precoces, reducir la incidencia de ETS, especialmente HIV-SIDA, promover el control médico de las adolescentes y mujeres embarazadas del partido, incentivar en los Centros de Salud el seguimiento ginecológico, propiciar la paternidad responsable. La finalidad hace visible su orientación, a saber “lograr que la familia se fortalezca en sus vínculos como educadora primaria en la consolidación de una persona educada sexualmente, para el amor y el respeto por el otro”, “formar a los educadores sanitarios, docentes, en educación sexual, con la finalidad de que se conviertan en educadores secundarios en la temática.” Además el programa “apunta a que los habitantes sean artífices de su propio estado de salud y propiciar la autogestión de la comunidad para el cuidado de su salud”.

Las principales acciones del programa son las educativas y comunicacionales desarrolladas a través de equipos interdisciplinarios. Para brindar asistencia y servicios de promoción, se han designado como referentes seis Centros de Salud ubicados geográficamente según diagnóstico de “necesidad poblacional” y área programática. No obstante, los 42 centros de salud existentes brindan servicios de ginecología (n=23), obstetricia (n=21) o ambos (n=13).

Un equipo municipal de educación sexual ofrece cursos y charlas de orientación e información a la comunidad (alumnos, padres, docentes, juntas comunales, otros) dirigiendo sus esfuerzos en la formación de instructores “para la educación sexual formal y humanizada”.

El Centro de Capacitación Municipal, con motivo de un diagnóstico realizado en el año 2000 en 300 escuelas públicas y privadas, detecta que el 48 % manifiesta incidencia de problemas de violencia y sexualidad, surgiendo así el Programa de Prevención y Educación Sexual y el Programa de Violencia, integrados en el Programa Educativo Integral en la Prevención de la Violencia y el Desarrollo de la Educación Sexual en las Escuelas. Este programa tiende a profundizar actividades de prevención específicas en adicciones y en enfermedades de trans-

misión sexual, disminuir los casos de violencia y los embarazos precoces en niños y adolescentes. La exclusión de la población no escolarizada constituye un problema evidente.

En síntesis, del análisis de los documentos de los programas se aprecian algunas cuestiones: a) las acciones de salud sexual y reproductiva se dirigen principalmente a las mujeres (por otra parte a ellas captan casi exclusivamente los servicios de salud, dificultando promover la responsabilidad masculina en sexualidad y fecundidad); b) las leyes ponen énfasis en la salud reproductiva y en mucho menor grado se contempla la salud sexual, término por otra parte cuestionable por su reduccionismo y connotación biomédica (Schuster y García Jurado, 2006); c) la salud reproductiva se piensa y dirige a adultas heterosexuales y los servicios de ginecología excluyen a los varones; d) la inclusión de los programas de salud sexual y reproductiva dentro del programa materno-infantil refleja el interés en la diáda, soslayando la sexualidad; e) se considera que la adolescencia debería abstenerse de la reproducción y las acciones prevenir y velar por los riesgos de las prácticas (hetero) sexuales[24]; f) los programas de atención de adolescentes se centran en conductas “de riesgo” (de hecho intervienen cuando se registran daños y los programas de prevención son escasos); g) la creación de servicios con atención personalizada, integral y dirigida a la atención de la salud reproductiva de las adolescentes no es contemplada en la legislación ni en los programas; h) en la provincia de Buenos Aires se protege especialmente a adultos (padres, médicos), posibilitando el desamparo de los derechos sexuales y reproductivos; h) en el partido de La Plata los programas dirigidos específicamente a los jóvenes, consisten en brindar charlas informativas a aquellos que se encuentran escolarizados.

Por tanto, a pesar de que el derecho a la salud reproductiva de los adolescentes está reconocido, las oportunidades y garantías no les están dadas existiendo asimismo barreras sociales, culturales y religiosas e institucionales que afectan su promoción.

En pos de identificar alguno de estos aspectos, es que indagamos la experiencia de maternidad desde la perspectiva de las propias adolescentes, la que no ha tenido la atención que amerita.

El campo de las subjetividades: los discursos

de las adolescentes

Las entrevistas realizadas dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones y experiencias que rodean a la maternidad adolescente.

Las entrevistadas tienen actualmente entre 17 y 22 años pero la edad media al nacimiento del primer hijo es de 16.3 años (la mayoría se concentra en los 16 y 17 años) y tienen un promedio de 1.9 hijos. Poco menos de la mitad ha nacido en provincias del interior del país (Corrientes y Misiones) o en países limítrofes (Perú, Paraguay y Bolivia). La mayoría convive con su pareja (en general pares en edad), en hogares extensos y nucleares en similares proporciones y la precariedad de las viviendas se agudiza en los hogares nucleares.

Tres no asistían a la escuela antes de quedar embarazadas, la mayoría la abandonó en esa oportunidad y sólo cinco retomaron luego sus estudios. Una ha completado el nivel secundario; las que retomaron lo están cursando pero la mayoría no logró completar 9 años de escolaridad básica. Actualmente un tercio trabaja esporádicamente en actividades precarias mientras que las que lo hacían antes de nacer el primer hijo, duplican esa proporción y todas carecen de obra social.

Podemos plantear que la participación en el mercado laboral no incidiría retrasando la edad al nacimiento del primer hijo. Asimismo, en nuestro país, las políticas para conciliar trabajo y familia son -en el mejor de los casos- débiles y frente a la dicotomía maternidad/trabajo, habida cuenta de las condiciones laborales ofrecidas a las mujeres pobres, la mayoría decide atender a sus hijos. La fuerza del rol materno se evidencia en que cualquier desajuste al mandato cultural provoca culpa, y en casos minoritarios frustración. Las ocupaciones que realizan (lavar ropa, servicio doméstico, contraprestaciones del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados), muy alejadas de las expectativas de realización personal, no resultan gratificantes ni redituables, responden en todos los casos a imperativos de subsistencia.

Antes del primer embarazo, los anticonceptivos eran conocidos por casi todas aunque utilizados por menos de la mitad.

“...no, él no quería cuidarse. Y yo no me cuidaba, quería tener también porque tanto cuidaba yo a mis sobrinos, entonces quería tener míos...” (Lucía).

“...estaba muy contenta. Siempre me conformaba cuidando los sobrinos (tiene 7 hermanas y todas habían tenido a partir de los 15 años; su madre tiene 27 nietos). Ya tenía 19 años y todas mis hermanas tenían hijos y yo era la única que estaba fuera de línea y allá en Corrientes la mayoría tienen de jovencitas, sí. Y de más jovencitas también, de 13 y 14 años. De la mayoría de ellas fui yo a más virgen digamos” (María José).

Las que no utilizaban métodos anticonceptivos concentra a las que fueron madres entre los 14 y 16 años. El temor a la reacción de los padres es una constante en estos casos:

“No, nunca. Ahora después de que tuve yo sí. Pero antes no, pero bueno, fue un descuido... pensaba ¿qué voy a hacer? porque era chica también, justo quedé encinta cuando tenía 15. Para contarle a mi papá me dio como miedo pero no, mi papá lo aceptó, todo bien” (Lorena).

Madres y hermanas mayores representan la principal, a veces exclusiva, fuente de información o agentes que intervienen en la adopción de métodos anticonceptivos:

“...yo sabía por mi mamá que desde que me hice señorita a los 12 me dijo y me llevó ella a la ginecóloga a hacerme todos los estudios, sobre todo cuando empecé a salir con él, me llevaba más” (Brenda).

La anticoncepción era compartida con la pareja en menos de la mitad de las que se cuidaba.

“...no. Totalmente imprevisto, pero hacía ya 5 años que éramos novios...nos cuidamos un tiempo y después no, en ese sentido éramos conscientes. (...) a la salita no, nunca había ido, mi mamá siempre me habló mucho. Somos más amigas que otra cosa. Me decía “cuídense”. Ella muchas veces me compró preservativos...pero obvio, no siempre le di bolilla” (Laura).

El contexto familiar incide en la búsqueda del embarazo, la mayoría de las veces motivado por condiciones hostiles o de violencia:

“...en verdad era chica, fue por bronca, para cortar con ellos” (Jenny).

Asimismo, es elocuente la influencia de los varones, padres o parejas, en las decisiones reproductivas:

“Hasta mi papá me habló a mí: un día me dijo, vamos a hablar en serio y me empezó a contar

porque ya sos señorita así que empezá a cuidarte porque los hombres cuando la quieren poner la ponen así que tenés que estar segura” (...) Empezamos a salir cuando yo tenía 14 años y me cuidé hasta que él quiso tener un hijo. Antes nos cuidábamos los dos (ella con pastillas que le daban en la salita y su pareja con preservativos que compraba). Me preguntó si quería tener un hijo con él y le dije que sí. Intentamos la primera vez y no quedé pero después sí, así que él estaba re-contento” (Brenda).

“No, contento porque él había pensado que no podía tener hijos, había estado con mujeres, en pareja estables queriendo tener hijos y no podían quedar embarazada así qué suponía que no podía tener hijos, igual nunca se hizo ningún estudio, así que contento” (Daiana).

“... por problemas familiares. Entonces, para que estemos juntos, teníamos que tener una criatura, un bebé para que él salga del Instituto. Entonces, por ahí vino el Nahuel, pero no vino porque nosotros... para que él se salga, lo queríamos nosotros. No nació como diciendo: “me olvidé de tomar las pastilla”, no nació así, nació porque nosotros quisimos” (Cintia F).

“Mi mamá no quería que lo tuviera porque tenía miedo a lo que dijera mi papá, tenía miedo a la reacción de él. Papá y mamá querían que tomara esa pastilla para perderlo así que me rajé a lo de mis tíos a Los Hornos. El quería hacerse cargo de la criatura y yo no quería perderlo porque después vas a quedar con remordimiento. Y después mis papás también se arrepintieron y tenían miedo de que me pasara algo a mí, no sé” (Aylén).

La importancia del sistema educativo en la información brindada sobre sexualidad y reproducción es reducida cuanti y cualitativamente en términos de transferencia y nulo en sus efectos[25]:

“...más o menos, esos informes que dan y te decían chicos, cuídense, pero lo normal, poquito” (Paula).

“...lo que me dieron en el colegio no me sirvió de nada, no entendí un montón de cosas. Fue una charla” (Cintia A).

Cabe señalar que la incorporación de contenidos sobre salud reproductiva en la currícula escolar es aún objeto de debate[26] y la información a través de pares puede ser inadecuada, lo

mismo que la que brindan los adultos, sumándose en ellos la posible manipulación o mala intención (Mabel Bianco, cit. por INFOBAE, 2008).

Por su parte, la escasa demanda a los servicios de salud antes del embarazo limita las posibilidades de prevención:

“...no, antes iba a pedir certificado de buena salud para la escuela” (Cintia F); “...me daba vergüenza ir a preguntar por las pastillas” (Lourdes); “...la primera vez que tuve un control fue cuando quedé embarazada” (Paola).

A partir del contacto con los servicios de salud con motivo del embarazo y parto, todas comenzaron a controlar la natalidad con anticonceptivos abriendo la posibilidad de no tener más o “tener pocos hijos e invertir a fondo (emocional y materialmente) en ellos” (Scheper Hughes, 1997: 385), meta que señala la mayoría.

“No, ya con mi marido dijimos basta, listo, cerramos la fábrica. Vino el varón que es lo que tanto queríamos. Aparte con ellos tres nos arreglamos bien. No les falta ni ropa ni comida que es lo más esencial, así que bueno basta. Nos llevamos bien con ellos tres, los queremos...creo que uno más no lo podría aguantar” (Paula).

Los métodos aceptados y utilizados por todas son las pastillas, manifestando resistencias hacia los métodos mecánicos.

“...porque han pasado casos, no sé si tanto del DIU pero creo del espiral, que han salido del espiral con los chicos en la cabeza, qué se yo, me da como impresión. También me da impresión como que tener algo que no es mío adentro del cuerpo, como que me da... no sé si es así pero... sé que hay gente que está a favor, pero a mí no me gusta, me da como impresión” (Paula).

Dos refirieron con reproche, haber abortado -en condiciones inseguras-, el primer embarazo obligadas por sus madres y dos plantearon que tal fue la propuesta de sus padres a la que se opusieron con vehemencia -fuga del hogar mediante-, pese a que no habían proyectado el embarazo y tenían escasa edad. Sentimientos de culpa y temor a los riesgos a su salud están en la base de tal resistencia:

“Fue por mi mamá, me dijo: -si lo tenés yo me vuelo de un tiro, yo no tengo nada que perder, no tengo marido. Lo único que te tengo es a vos, sos mi única hija-. Y después de eso aborté. Y a

la semana me escapé de mi casa y me vine para acá. Eso fue en febrero y en diciembre ya estaba embarazada de Abril” (Daiana).

“...mi papá. Me costó mucho decirle. En su momento fue la persona que me dijo si me lo quería sacar, que él me pagaba todo. Y como yo le dije que no, quedó ahí, nunca más hablamos y le costó mucho acercarse al nene” (Aylén).

Si bien no es posible soslayar a los adultos, es claro también que las adolescentes muestran capacidad de decisión, siendo ellas, más que los adultos, quienes interpretan y defienden sus derechos.

Una refiere haber pensado autónomamente en recurrir al aborto y haber desistido, no por conflictos morales sino por inseguridad y temor:

“Pensé en sacármelo pero no conocía a nadie acá y no sabía qué hacer si llegaba a tener complicaciones” (Alicia).

La mayoría no buscó el embarazo, hecho que les era previsible:

“En el colegio sí, dieron charlas sobre anticoncepción, en el comedor de Marito también, mi mamá también me hablaba mucho sobre eso. Yo no quería quedar embarazada en esa edad que tenía. Pero pasa que cuando está caliente -perdón la palabra- no pensás en nada, y estábamos así los dos” (Aylén).

Más de un tercio buscó el embarazo, predominando la decisión compartida aunque también sólo la de sus parejas, representando un acontecimiento que afianzó la fidelidad, ratificó la fertilidad del varón y a veces respondió a la expectativa de éste vinculada al sexo privilegiado:

“le di un varón” (Patricia).

Los sentimientos ante la constatación del embarazo se muestran positivos: “lloraba de alegría” (Brenda), ambivalentes: “estaba contenta pero no quería que nadie se enterara, tenía miedo, vergüenza, qué se yo” (Paola), negativos: “me quería matar” (Paula), o indefinidos: “nada, ni bueno ni malo, algo que puede pasar y bueno...” (Joanna).

En estos casos, manifestaron resignación frente al destino inherente a su sexo.

Como en los sectores pobres la maternidad temprana es frecuente y más aceptada, para muchas ella constituía “el” proyecto de vida:

"Me gusta ser mamá, siempre pensé en ser mamá y que quería tener 2 o 3 hijos" (Brenda); "quería ser mamá, siempre pensé eso" (Lucía); "yo siempre me sentí como mamá" (Paola); "a mi edad mis hermanas ya habían tenido todas, y yo no" (María José), apreciaciones recurrentes en las adolescentes que han sido hijas de familias numerosas.

En el caso de las que han sido hijas mayores en familias numerosas, la maternidad no implica cambio marcado de roles sino continuidad de lo que venían haciendo desde temprana edad:

"Tengo experiencia por cuidar a mis hermanos. Desde los 7 años cocinaba, cuidaba a mis hermanos, los cambiaba, todo... porque mi mamá trabajaba" (Jenny). "Yo crié a mi hermana, yo tenía 12 años y la crié así que más o menos sabía" (Brenda). "... yo siempre me sentí como mamá porque yo siempre le crié a mis sobrinos todos, les cambiaba... Yo cuando le tuve a mi bebé no tuve problema en cómo cambiar un pañal nada porque yo ya sabía todo, ya sabía darle mamadera, todo" (Lucía). "Como criás a tus hermanos sabés... y más joven podés disfrutarlo más" (Ayelén).

Como señala Juliana Marcús (2005) el rol maternal les brinda recompensas y gratificaciones que no encuentran en otros ámbitos de sus vidas. El valor afectivo de los hijos y la función de compañía que les asignan es destacado por todas las entrevistadas.

"...yo estoy feliz con ellos, porque tuve una infancia no muy linda tampoco. Nunca pensé que iba a tener mis hijos, que iba a estar acá o algo. Y estoy bien, de donde estaba" (Lorena).

"...ellos van a hacerme compañía. Por lo menos ellos están conmigo todo el día" (Lucía).

En otros casos, el embarazo frustró la concreción de proyectos dirigidos a completar estudios y a emprender una carrera.

"Las desventajas que puedo llegar a ver es que no llegué a ser lo que yo quería, a tener la carrera de policía que yo quería. Por eso estoy terminando el secundario. Yo quería eso apenas salía del secundario pero bueno, no pude... pero por eso mismo estoy terminando el secundario" (Laura).

"Me hubiera gustado estudiar peluquería. Pero dije: -bueno, cuando crezca Juani- y después me

quedé justo del ella, pero todavía puedo anotar-me" (Lorena).

"...muchos proyectos no, yo les decía terminar la secundaria y empezar alguna carrera, pero como no me gustaba ninguna... mi problema era terminar la secundaria aunque sea y después ver en el momento que pasaba. Y en el momento vino Rocío así que... a mí siempre me gustó ser maestra jardinera igual. Yo siempre dije, cuando sea un poco más grande voy a retomar porque yo soy joven todavía..." (Paula).

Aunque aparece como norte la realización personal en el trabajo o en el estudio, todas lo ubican en un lugar subordinado a las necesidades de sus hijos: "para poder darles lo mejor" (Cintia A), "para que tengan lo que yo no tuve" (María José), "Yo antes quería hacer medicina, me gustaba ser médica forense (por el programa de TV) pero como no se puede no. Ahora lo único que quiero es estar con ella nomás, con estar con ella me conformo" (Ayelén). "...terminar el Colegio y terminar alguna carrera para que mi hijo esté orgulloso de la madre, nada más. Si seguí la escuela era porque mi abuela me dijo que lo haga por el nene, porque sino tampoco la seguía" (Cintia F).

Tales proyectos se definen en función de otros, y se subordinan a la estructura machista que han internalizado:

"...antes cuidaba a unos nenes y después no porque no querían que hiciera fuerza así que no fui más. Cuando me enteré que estaba embarazada mi marido no quería que haga fuerza, mi papá tampoco, así que tuve que dejar" (Brenda).

"...porque mi marido mucho no quiere, no le gusta que yo salga a trabajar porque dice que para qué tiene las dos manos él, 'que yo tengo que traer'. Y yo tengo que estar en la casa cuidando a mi hijo y limpiando. 'Para eso están las mujeres' dijo. (...). Él no quiere que yo trabaje, hasta me pide que deje la escuela; cuando llega quiere que lo atienda, y tiene razón. (...) tengo el mismo derecho que él de salir a trabajar. Pero pasa que si yo salgo a trabajar abandono a mi hijo" (Cintia F).

Las diferencias son asumidas como funcionales o instrumentales, en todas subyace la idea que "mi casa es mi reino" y ellas las reinas de los afectos y para ser un buen padre y madre debe existir una clara división del trabajo. Si

bien las normas y relaciones pueden ser más laxas en la vida conyugal, las atinentes a la maternidad siguen siendo inflexibles.

“...yo estoy todo el día metida acá adentro y es poco lo que salgo. Porque yo adonde voy va mi hijo. Eso es lo que tengo, y sino le podés preguntar a cualquiera, que nunca ando sola. Si ando sola es por un trámite(...) porque ahí estás demostrando que a tu hijo no lo dejás para irte por ahí, no lo dejás con cualquiera” (Cintia F). Yo me la paso todo el día en mi casa, yo antes salía y ahora no, cambié un montón” (Brenda).

Estas apreciaciones nos hablan del poder que no se ve pero que actúa, aquel que ha colonizado la subjetividad. Tal complicidad abona la idea de Pierre Bourdieu (2000) para quien la lógica del género es la forma paradigmática de la violencia simbólica. El énfasis en la postergación, entrega y sacrificio aparecen recurrentemente en las entrevistas como requisitos de lo que debe ser una buena mujer/esposa/madre. Uno de los elementos constitutivos de las identidades de género es el considerar que la condición biológica que permite engendrar, se liga a una habilidad innata para criar y ser amas de casa, desempeñando un rol subordinado a los hombres (Climent, 2007:158).

Todas parecieran asumir una perspectiva conservadora sustentada en bases morales (la diferencia es correcta) y biológicas (esencialismo). El esencialismo se hace visible también en la consideración del “instinto” de los hombres, siendo las mujeres víctimas de ese impulso. De allí que, como aparece en citas anteriores, los padres tratan de incidir en sus hijas para que se prevengan de esa fuerza: son ellas las que se tienen que cuidar, no puede decir que no.

La mayoría afirma las ventajas de ser madre joven, independientemente de la planificación.

“...más joven podés disfrutarlo más”; “aprendés más cosas cuando sos mamá joven”; “gracias a Dios que soy mamá joven porque cuando crezca vamos a hablar como amigas”.

La referencia a la mayor capacidad de disfrute, de paciencia, a la posesión de habilidades especiales para desempeñarse como madres refleja la internalización del maternalismo:

“A mí me parece que no importa la edad, porque si tenés un hijo...es todo y más si está bien con tu esposo. No es más difícil tampoco ser

madre de joven, te dicen tantas cosas que... pero no es tanto y además son cosas que ya hacés” (Aylén).

Es posible ver en la maternidad una forma de afirmación de la subjetividad a través de la adquisición de un nuevo status; todas consideran que el rol de padre es difícil de asumir e interpretan que las mujeres tienen ventajas comparativas: *“...están acostumbrados a salir, la mujer no” (Cintia A); “enseguida se cansan de los chicos” (Cintia F); “...les gusta salir, joder” (Brenda); “...la madre es todo, es más que el padre” (Aylén); “no cambian tanto, salen, siguen con sus cosas” (Paola). “...porque el hombre siempre es más inmaduro, la mujer madura cuando es madre, el hombre no” (Laura); “...no lo veo al hombre, porque el hombre es como muy dejado digamos. Aparte la mujer es más cuidadosa, está en todo, arregla todo... Siempre estoy pendiente. Primero es ellos y después lo demás” (Lorena).*

Si bien los hombres han aumentado su participación en las tareas del hogar, están lejos de alcanzar los niveles de responsabilidad que tienen las mujeres y según muchas entrevistadas, es nula: *“no está casi nunca, está en el trabajo todo el día..., el padre nunca está” (Alicia).*

Los progenitores de las adolescentes, en su mayoría e independientemente de la reacción inicial ante el embarazo de sus hijas, las acompañaron y acompañan en las tareas de crianza. En aquellas que viven en hogares extendidos, la colaboración de familiares, especialmente madre y hermanas, resulta sustancial. Esta situación compensa la falta de guarderías estatales y posibilita ciertos reemplazos en el desempeño de su rol, permitiendo a veces completar la escolaridad.

La mayoría percibe que, con motivo del embarazo, los adultos las miran con compasión (agentes institucionales predominantemente) y reproche (especialmente familiares y vecinos):

“...te dicen: -te arruinaste la vida, tan joven ¿a vos te parece? -. Y yo no me arruiné la vida, yo los quiero, son mis hijos. Sino no los hubiese tenido” (Paula).

Y con lástima, porque todo el mundo te dice: -¡qué lástima, tan joven!-. Y yo pensaba: pero si es mi hijo y lo quiero” (Lourdes).

“Me decían “ah pobre, que chiquita” y medio que te molesta a veces eso. Porque no lo veo como “pobre” tampoco, porque uno capaz que lo buscó o fue contenta a contarlo. Pero me miraban medio con lástima, pobre, sí. Yo no lo veo “pobre” tampoco, porque uno tiene su vida y bueno... pero yo soy feliz con ellos” (Lorena).

Con relación a los programas sociales, ninguna es destinataria de alguno dirigido específicamente a madres adolescentes. A través del Programa Materno Infantil reciben leche en los controles de salud, algunas reciben irregularmente y en reducida cantidad alimentos del Plan Vida y sólo tres reciben mensualmente el equivalente \$ 150 a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados o del Plan Familias dirigidos a hogares pobres. Muchas habían sido convocadas a participar de charlas y talleres vinculados a la salud materno-infantil en distintas instituciones barriales, las que -como plantea Dieren (2004)- parten del supuesto de que las amas de casa tienen tiempo disponible y que la reproducción es una responsabilidad intrínsecamente femenina. En nuestro país, la apelación a las mujeres para que participen de programas que apuntan a la promoción -en este caso de la salud- y al empoderamiento, se funda en los roles domésticos tradicionales o bien las abstrae de las condiciones concretas que posibilitarían su participación. En general, las actividades propuestas a las adolescentes entrevistadas estaba dirigidas a la formación de capacidades individuales o a la asignación de tareas en el espacio público comunitario (limpiar terrenos del barrio “para cuidar la salud de los chicos”).

En cuanto a los servicios de salud, la buena atención del personal parecería mitigar las condiciones de los servicios. Asimismo, las dificultades para conseguir turnos y las demoras en la atención se asumen como dadas.

Comentarios finales

Las condiciones de vida de las entrevistadas reflejan una situación de desventaja social evidente -no percibida como injusta en todos los planos- y limitaciones de los programas de salud para prevenir situaciones o “conductas de riesgo”, en todo caso difíciles de alterar si no cambian las estructuras de desigualdad que las promueven.

Las limitaciones de los programas de salud se

derivan de haber medicalizado un comportamiento resistente a la normatización, de la imprecisión en los parámetros para definir salud/enfermedad y su relación con la normalidad/anormalidad biológica, del etiquetamiento de la adolescencia, de una mirada restringida de la sexualidad y la reproducción, de la omisión de abordajes transversales, del desconocimiento / negación de los derechos, de su permeabilidad a presiones sectoriales, de la precariedad de servicios y recursos, entre otros factores.

Los servicios de salud ingresan en la vida de las adolescentes con motivo de su embarazo y a partir de allí se las considera desde su rol reproductivo favoreciendo el control de la natalidad y actuando los programas materno-infantiles en pro de la salud de sus hijos. La inclusión del programa de salud sexual y reproductiva dentro del Programa Materno-Infantil ejemplifica cómo a través del estado se construyen y reproducen perspectivas de género y cómo la rotulación de programas contribuyen a reforzar estereotipos.

Las intervenciones propuestas en los lineamientos de los programas se limitan al individuo y no promueven cambios en las relaciones de poder, ofreciendo beneficios sin derechos (Daeren, 2004). Además, los programas y servicios tampoco ofrecen orientaciones sobre la asistencia judicial. En tal sentido contrastan los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales y reconocidos como derechos constitucionales con el funcionamiento de programas e instituciones.

Las entrevistas dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones y experiencias en torno a la maternidad adolescente, su relativa marginalidad respecto de los enclaves institucionales que pretenden su control y la gravitación de la familia en sus trayectorias como madres.

Con relación a esto último, tal como se constata en los relatos, la familia es un espacio de distribución de recursos y de poder y las relaciones intrafamiliares un mecanismo de socialización que promueve la desigualdad. Además, se observa también que “la naturaleza de la vida familiar requiere que no se ponga énfasis explícitamente en los elementos conflictivos y a veces las mujeres desfavorecidas no pueden siquiera evaluar sus privaciones relativas” (Sen, 2000: 237). Han interiorizado de tal forma su posición subordinada que no tienen sentido de aquello a que tienen justo derecho como personas.

Las situaciones estudiadas muestran que los roles y espacios propios de las mujeres y de los hombres permanecen intactos. La asimetría en las relaciones de género y edad se constata en la autoridad que ejercen en primer lugar los hombres y luego los adultos sobre las adolescentes en las decisiones y percepciones sobre la sexualidad, la reproducción y la maternidad. En ellas, la incidencia de las leyes aún no se hace sentir.

Pero, en tanto el locus de generación de género se ubica en la esfera privada, en la vida cotidiana, hay que pensar en ese lugar porque la ampliación de derechos, aunque sea mínima, comienza allí (Di Marco, 2005).

El grupo estudiado está sometido a ambos tipos de injusticia (económica y cultural) de modo que requiere necesariamente políticas de reconocimiento y de redistribución. Hay que tener en cuenta que la mayor o menor orientación de las políticas hacia alguno de estos tipos de injusticia, corre el riesgo de favorecer las desigualdades: *“una aproximación dirigida a resolver las injusticias de redistribución puede terminar generando injusticias de reconocimiento”* (Fraser, 1997: 42). Tal como se desprende de la letra y las acciones de los programas, el supuesto de que mejorando la distribución de recursos se mejora el reconocimiento, tiene como resultado la reproducción de roles y la reproducción de beneficiarias.

Lidiar con retórica de la universalidad de los derechos frente a la evidencia de su conculcación en actores subordinados a través de relaciones de clase, género y edad, con diferentes percepciones y representaciones sobre sus derechos supone, siguiendo a Fraser (1997), ensayar políticas transformativas que tiendan a deconstruir y desestabilizar las diferencias entre los grupos. Lejos están de ello los programas y las prácticas institucionales.

La progresiva integración de la problemática planteada dentro del discurso de derechos y las luchas por la ampliación de los mismos, tendría que comenzar por revelar en qué medida los programas pueden, buscan o deberían incidir transformadoramente en las relaciones de desigualdad más naturalizadas.

La vigencia de derechos obliga a prestar atención a estos -y otros- grupos vulnerados y a presionar por garantizarles igualdad de oportunidades. Y para esto, hay que garantizar igualdad de trayectorias, compensando desigualdades iniciales.

Bibliografía

- Adasko, Ariel (2005) “Perspectivas socioantropológicas para la adolescencia, la juventud y el embarazo” en Gogna, M. (coord) *Embarazo y maternidad en la adolescencia*, CEDES, Buenos Aires.
- Amorós, Celia (2000) “Elogio de la vindicación”, en Ruiz, A. (Comp.): *Identidad femenina y discurso jurídico*. Biblos, Fac. Derecho, UBA. Buenos Aires.
- Binstock, Georgina y Pantelides, Edith (2005) “La fecundidad adolescente hoy: diagnóstico socioedemográfico” en Gogna, M. (coord) *Embarazo y maternidad en la adolescencia*, CEDES, Buenos Aires.
- Birgin, Haydée (2003) *Darle poder a la ley: herramientas de acción ciudadana*. En Faur y Lamas (comp) *Derechos universales, realidades particulares*, UNICEF, Buenos Aires.
- Bourdieu, Pierre (2000) *La dominación masculina*, Barcelona, Anagrama.
- Butler, Judith. (1996) “Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault” en Lamas, Marta (comp.) *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*, PUEG/Miguel Porrúa Editores, México.
- Cardacci, Dora (2006) “Ordenando relatos. Investigaciones sobre salud y género en programas mexicanos de estudios de la mujer” en *Salud Colectiva -Salud y Género- vol 2 N° 1*, Universidad Nacional de Lanús.
- CELS-CEDES (informe final) (2005) “La salud y los derechos sexuales y reproductivos avances y retrocesos” CEDES, Buenos Aires.
- Climent, Graciela Arias, Diana (2000) “Representaciones sociales y comportamientos reproductivos de las mujeres de sectores populares”, *Cuadernos Médico Sociales* N° 70, Rosario.
- Climent, Graciela (2007) “Aprendizajes escolares, sexualidad y embarazo en la adolescencia”. En López, E. y Pantelides, E. *Aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva*, CENEP/CEDES, AEPa, UNFPA, Buenos Aires.
- Checa, Susana (2005) *Género, sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia*. Ed. Paidós, Buenos Aires.
- Chiara, Magdalena (coord.) (2003) *Plan de Acción Materno infantil julio 2000 a junio 2002*. Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires.
- Daeren, Lieve (2004) “Mujeres pobres ¿prestadoras de servicios o sujetos de derecho? Los programas de superación de la pobreza en América Latina desde una mirada de género”, CEPAL, Quito.
- Di Marco, Graciela (2005) *Democratización de las Familias*, UNICEF, Paidós, Buenos Aires.
- Faur, Eleonor y Gherardi (2005) “Sexualidades y reproducción: la perspectivas de los derechos humanos” En: *Informe sobre género y derechos humanos*. Equipo Latinoamericano de Justicia y género. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Foucault, Michel (1980) *La Historia de la Sexualidad*, Siglo XXI ed., Madrid.
- Fraser, Nancy (1991) “La lucha por las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío”. *Debate Feminista*, Año 2, vol 3, México.
- Fraser, Nancy (1997) *Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición ‘postsocialista’*. Universidad de Los Andes- Siglo del Hombre Editores, Bogotá.
- Gogna, M (comp.) (2003) *Las reformas en el sector salud en la Argentina y Chile*, CEDES/BID, Buenos Aires.
- Gogna, Mónica (2005) *Estado del arte: investigación sobre sexualidad y derechos en la Argentina: 1990-2002*, CEDES, Buenos Aires.
- Gogna, Mónica et al. (2005) “Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas”, CEDES, Buenos Aires.
- Guber, Rosana (1991) *El salvaje metropolitano*, Editorial Legasa, Buenos Aires.
- Guzmán Virginia (2001): *La institucionalidad de género en el estado: Nuevas perspectivas de análisis*. Unidad Mujer y Desarrollo, Serie Mujer y Desarrollo 32, CEPAL-ECLAC, Santiago de Chile.
- INFOBAE (2008) “Cada vez hay más casos de embarazo adolescente”, Artículo de Bárbara Roesler, 11 de abril de 2008, www.infobae.com
- Kabeer, Nayla (1994) *Realidades Trastocadas, Las jerarquías de gé-*

nero en el pensamiento del desarrollo, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, Editorial Paidós, México.

López, Elsa y Pnatelides, Edith (2007) *Aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva*, CENEP/CEDES, AEPA, UNFPA, Buenos Aires.

Lupica, Carina y Cogliandro, Gisell (2007) *Anuario de la maternidad Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina*, Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires.

Llobet, Valeria (2006) "Las Políticas sociales para la infancia vulnerable. Algunas reflexiones desde la Psicología". En *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. Vol. 4, N°1.

Marcús, Juliana (2006) "Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido que las mujeres le otorgan a la maternidad", en *Revista Argentina de Sociología* vol. 4 N° 7, Buenos Aires.

Mead, Margaret (1993) *Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas*, Ed. Paidós, Buenos Aires.

Mead, Margaret (1993) *Masculino y Femenino (1949)*, Editorial Paidós, Buenos Aires

Menéndez, Eduardo (1997) "El punto de vista del actor. Homogeneidad, diferencia e historicidad", en *Relaciones* N° 69.

Moller Okin, Susana (1996) "Desigualdad de género y diferencias culturales" en *Castells Carmen Perspectivas feministas en teoría política* Paidós, Barcelona.

Paiva, V. (2000) *Analizando cenas e sexualidades: a promocio de saude na perspectiva dos direitos humanos*, NEPAIDS, San Pablo.

Palomar Vereá, Cristina (2004) "Malas madres: la construcción social de la maternidad" en *Debate Feminista*, año 15, vol. 30, México.

Pantelides, Edith Alejandra; Mychaszula, Sonia M.; Gaudio, Magalí (2005) *Salud sexual y reproductiva adolescente en el comienzo del siglo XXI en América Latina y el Caribe FNUAP; CENEP*, Buenos Aires.

Pecheny, Mario (2000) "Sobre el cuidado y el riesgo". Ana Lía Kornblit, ed. *Siglo XXI*, Buenos Aires.

Petracci, Mónica y Ramos, Silvina (2006) *Política pública de salud y derechos sexuales y reproductivos*. UNFPA/CEDES, Buenos Aires.

Scheper-Hughes, Nancy (1997) *La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en Brasil*, Ed. Ariel, Madrid.

Scott, Joan (1997) "El género: una categoría útil para el análisis histórico" en Navarro, M. y Stimpson, A. (comp.) *Un nuevo saber. Los estudios de mujeres. Sexualidad, género y roles sexuales*, FCE, México.

Sen, Amartya (2000) *Desarrollo y libertad*, Ed. Planeta, Buenos Aires.

Shuster, Gloria y García Jurado, Mariana (2006) "Análisis comparativo de la legislación nacional y provincial en maternidad de salud sexual y reproductiva" en Petracci y Ramos (comp.) *La política pública de salud y derechos sexuales y reproductivos en la Argentina: aportes para comprender su historia*, CEDES/UNFPA, Buenos Aires.

UNICEF-INDEC (2003) "Situación de los niños y adolescentes en la Argentina 1990-2001", *Serie de Análisis Social 2*, Buenos Aires.

Referencias bibliográficas y notas

[1] Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación más general sobre pobreza, políticas sociales y género, dirigido por Amalia Eguía y Susana Ortale, radicado en el CIMeCS y el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación de la UNLP, que cuenta con el apoyo de subsidios del CONICET, la CIC, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina

[2] Ver Objetivo 3 de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe país 2005. Proyecto PNUD/Arg./04/046. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación.

[3] Por problemas de espacio se omite información sociodemográfica y epidemiológica vinculada a la maternidad adolescente, la que puede consultarse en los trabajos de Binstock y Pantelides (2005); Faur y Gherardi (2005); Lupica y Cogliandro (2007); CELSAM (2005 cit. por INFOBAE, 2008), entre los más relevantes.

[4] CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

[5] Ver página del CoNDeRS: http://www.conders.org.ar/pdf/LEY_n_25673_comentarios.pdf

[6] Los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con garantizar el bienestar general, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, se caracterizan por ser derechos colectivos que requieren de la actuación del Estado y su acceso, lejos de ser de aplicación automática, es dependiente de "las condiciones económicas de cada nación".

[7] Art. 264 del Código Civil

[8] En ella importa el cumplimiento de los derechos consagrados en Tratados Internacionales, incorporados en 1994 en la reforma de la Constitución Nacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros.

[9] Debido a las dificultades de encontrar información actualizada sobre proyectos o programas de la gestión municipal iniciada en el 2007, se analizan los programas que funcionaron en el período anterior.

[10] La Plata, municipio de 600.000 habitantes, capital de la provincia de Buenos Aires. Las tendencias en sus características socioeconómicas, son tributarias y en muchos sentidos representativas del conjunto de aglomerados urbanos de la provincia.

[11] En ella importa el cumplimiento de los derechos consagrados en Tratados Internacionales, incorporados en 1994 en la reforma de la Constitución Nacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros.

[12] Ver página del CoNDeRS: http://www.conders.org.ar/pdf/LEY_n_25673_comentarios.pdf

[13] Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN), nuestro país por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad (Ley 23.849).

[14] En concordancia con la CIDN, se entiende por interés superior del mismo, el ser beneficiarios, sin excepción ni discriminación alguna, del más alto nivel de salud y dentro de ella de las políticas de prevención y atención en la salud sexual y reproductiva en consonancia con la evaluación de sus facultades.

[15] Recién en 2002, se promulga la Ley Nacional 25584 (2/5/2002) vinculada con las prohibición de acciones discriminatorias hacia alumnas embarazadas en las escuelas públicas del país, siendo sustituida un año y medio después (Ley N° 25.763 mediante) por la Ley Nacional 25.808 que incluye a los establecimientos privados, a los alumnos progenitores, y además especifica protecciones durante el período de lactancia.

Tres años después de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual (Ley Nacional 26.150; 10/2006) estableciendo que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y privados aunque "con una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente".

[16] <http://www.ms.gba.gov.ar/programas/Maternoinfantil.html>

[17] http://www.ms.gba.gov.ar/programas/Maternoinfantil_Saludsexual.html

[18] Los datos que contiene para el tema que nos interesa, corresponden a 1995-1997.

[19] Programa Materno Infantil de la Provincia de Buenos Aires: Encuesta provincial nutricional en niños y embarazadas. Ministerio de Salud. La Plata. 1995.

[20] Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. Programa Materno Infantil: Sistema Informático Perinatal, 1995-1997.

[21] MSAS: Programa Nacional de Estadísticas de Salud N°41: Estadísticas vitales. Información básica 1997.

[22] http://www.ms.gba.gov.ar/programas/Maternoinfantil_Saludsexual.html

[23] Informe de Gestión, Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, 2002 (informe de circulación restringida).

[24] Vinculada a la tendencia, cuyo debate instaló entre otras Judith Butler (1996), a asimilar sexo y género y a identificar relaciones sexuales con heterosexuales.

[25] La mayoría de las entrevistadas tenía rezago escolar antes del embarazo, y cursaba en niveles inferiores a los establecidos por el sistema educativo para dictar contenidos sobre el tema.

[26] La incorporación en el 2004 de la asignatura Salud y Adolescencia -dentro del nivel Polimodal- por parte de la Dirección General de Escuelas de la Pcia. de Bs. As., fue objeto de observación y resistencia de la Arquidiócesis local.

*** Dra. Susana Ortale**

Antropóloga.

Posdoc en Ciencias Sociales (CEA/CONICET, Universidad Nacional de Córdoba). Especialista en Evaluación de Políticas Sociales (UNSAM).

Investigadora Independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Directora del CEREN, centro CIC/PBA, que realiza actividades de investigación y transferencia en el campo de la alimentación, la crianza, el desarrollo infantil y de las políticas sociales dirigidas a población materno-infantil y adolescente.

Investigadora en distintos proyectos sobre pobreza, estrategias de reproducción, desigualdades de género y edad y políticas sociales radicados en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales (dependiente del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales CONICET/UNLP-).

Profesora de “Antropología Cultural y Social” (FaH-CE-UNLP) y de diversos seminarios de posgrado.

LA CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD. “PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL INDIO SANO”, DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO



PROF. DR. JUAN REICHENBACH

“Desde la iniciación de mis estudios, me di cuenta que el porvenir de la medicina estaba cifrado en la higiene pública y social y que la misión real del médico era ante todo prevenir la enfermedad. En vez de médico de enfermos lo he sido de ciudades y pueblos”. Dr. Emilio Coni. 1919.

Sumario

La comunidad sabe de salud. Lo aprendí en una de mis experiencias inolvidables de vida e ilusión en mi comarca de origen: Partido de Punta Indio, Verónica, hace ya unos cuantos años.

El partido se dividió del de Magdalena, a la vera del Río de La Plata.

Mi tierra es una tierra de inmigrantes y de encuentros. De cooperativas, de gente laboriosa y solidaria.

Me tocó ser el Director de Desarrollo Social y Salud de la nueva comuna y coordinar un plan de salud unguído desde las bases de la comunidad, en las casas de los vecinos, en asambleas en la esquina, en los ranchos del distrito. Con gran participación comunitaria. Aplicando la sabiduría ancestral de nuestra gente.

El documento inicial de esta gesta fue, previo a la independencia del nuevo partido, el *Acuerdo-compromiso entre los partidos políticos, representantes del pueblo, Asociaciones y entidades del futuro Partido*, cuyos ejes incluyo:

- ✓ Vocación Autonomista.
- ✓ Vocación por una Democracia Participativa.
- ✓ Elección por parte del Pueblo de los Dele-

gados Municipales.

- ✓ Aspectos Económicos y Presupuestarios guiados por la comunidad.
- ✓ Equidad, eficiencia y calidad.
- ✓ Federalismo político y económico.
- ✓ Se alentarán, impulsarán y apoyarán los sistemas cooperativos existentes.
- ✓ Se promoverá la radicación industrial.
- ✓ Vocación Conservacionista.
- ✓ Acciones comunitarias prioritarias:
 - Educación
 - Salud
 - Cultura
 - Arte
 - Deporte
 - Producción

El rol de este moderno Municipio quedará limitado a:

- ✓ fomentar, incentivar, estimular, asistir y coordinar la ejecución de dichas actividades.
- ✓ Evitar la creación de nuevas estructuras burocráticas municipales.
- ✓ COMPROMISOS SECTORIALES
- ✓ Debe incluir a todos los sectores sociales conscientes de la necesidad de su protagonismo y responsabilidad en la nueva realidad que los involucrará, con plena vocación solidaria.

En interminables asambleas a lo largo de los dos años previos a la creación del Partido nos fuimos organizando. Me tocó coordinar los temas de Salud, con multitudinaria participación de los vecinos. Creamos los Consejos Locales

(localidad por localidad) y el Consejo Federal de Salud (que era representativo de todo el distrito). La convocatoria fue espontánea para todo vecino que quisiera ocuparse de su salud y la de su pago chico. Meses antes de la creación del Partido elaboramos, por amplia mayoría y con gran participación, el Documento de Pipinas.

Documento de Pipinas

*(Momento fundacional del Sistema de Salud Universal Indio Sano. Otoño del '95 Programa preliminar Indio Sano. **Programa de Salud y Acción Social Indio Sano** / Dr. Juan Reichenbach)*

Introducción

...El nuevo municipio de Punta Indio tiene una historia por vivir: la de todos.

Sus viejos, adolescentes, niños y embarazadas son los puntos cardinales de su nueva geografía.

La comunidad organizada en sus diferentes formas asociativas y de participación el terreno ancho y generoso de su futura semilla.

La salud entre todos, una de sus metas irrenunciables

Recién nace el **Indio Sano**, un proyecto de salud original, único, para todos, surgido de la inspiración de las voluntades colectivas.

No creemos en el impacto de cifras, gráficos o tasas, si representan solo el trabajo enquistado de unos pocos desde alguna alejada oficina. Creemos en la energía de los tantos, desde la esquina de algún barrio, multiplicados por las ansias de una vida digna y sana, partícipes incondicionales de este, su proyecto.

Nuestro propósito es simple, como el de los grandes desafíos: levantarnos alegres un día de sol, criar niños fuertes, proteger abuelos sabios, adolescentes poderosos, y embarazadas florecidas.

Nuestro plan prioriza el mantenimiento de la salud, la promoción, la prevención y la anticipación.

En lo que se refiere a su estrategia funcional básica, el mismo se estructura en la atención primaria de la salud.

Subprogramas

- ✓ Médico y enfermera de familia.
- ✓ Policlínico Docente.
- ✓ De emergencias médicas municipales
- ✓ De comunicación e informática

- ✓ Historia única de salud y enfermedad municipal
- ✓ Normatización de criterios de diagnóstico, tratamiento y derivación de las patologías prevalentes de las cuatro especialidades básicas
- ✓ De laboratorio y exámenes complementarios básicos
- ✓ Vademécum municipal básico
- ✓ De educación continua para la salud comunitaria
- ✓ De educación continua de pre y postgrado para todo el equipo de salud.
- ✓ De trabajadores de Atención esencial de la salud.

Todos los subprogramas responderán a las necesidades surgidas de los grupos de la comunidad organizada, verdadera expresión representativa de cada habitante de toda nuestra geografía.

El programa **Indio Sano** concibe a la salud como un derecho irremplazable del individuo, considerando que la misma debe ser igualitaria, justa, accesible, equitativa, continua, de todos y para todos.

El protagonista de la salud será el ser humano que interactúa en su medio familiar, social, económico, ecológico y político. El equipo de salud promoverá la integración igualitaria de todas las disciplinas en el logro de los objetivos comunes.

El programa prioriza la mantención de la salud sobre el tratamiento de la enfermedad; la prevención, la promoción y la anticipación del bienestar comunitario sin descuidar la curación y la rehabilitación de los enfermos.

La atención primaria de la salud será jerarquizada mediante el **Subprograma del médico y la enfermera de familia** que atenderán en forma permanente la salud de 200 familias y/o 1000 personas en áreas científicamente estudiadas.

Se normatizarán los 10 motivos principales en las 4 especialidades básicas lo que permitirá la atención organizada del 80 % de los problemas de salud de la población.

Documento del Consejo Vecinal Federal de Salud del Partido de Punta Indio.

Participación comunitaria. Una realidad preocupante

Los consejos vecinales elaboraron declaraciones en simultáneo, indicando:

- ✓ La existencia, cada vez mayor, de grandes sectores de población carentes de atención adecuada, ya sea por insuficiencia en los servicios médicos o por problemas geográficos, económicos o culturales, o por desconocimiento de algún otro tipo de cobertura, aparte de la institucional.
- ✓ La aplicación de los escasos recursos existentes y la incorporación creciente de tecnología sofisticada y costosa, basada la mayoría de las veces en modelos extraños a la realidad de estas áreas, que casi nunca son adecuados para resolver las necesidades básicas del grueso de las poblaciones.
- ✓ La escasa o nula participación comunitaria en proyectos de salud y desarrollo.
- ✓ El apoyo comunitario al **Plan de Salud Municipal INDIO SANO**, del Municipio de Punta Indio, que debe garantizar

1. Asistencia sanitaria apropiada
2. Adecuados servicios de protección, fomento, asistencia y rehabilitación de la salud, puestos al alcance de todos los individuos y comunidades, por medios que les sean aceptables, con su plena participación y a un costo accesible para lograr una necesaria integración con todos los demás sectores involucrados en el desarrollo de las comunidades.

3. En esa definición se encuentran señaladas explícitamente tres características que hacen a la esencia misma de la estrategia

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA / TECNOLOGÍA APROPIADA/ ACCIÓN MULTISECTORIAL.

Las cualidades principales de una participación comunitaria ideal son las siguientes:

- Activa en el Mayor Grado Posible
- Consciente, Responsable, Voluntaria. Solidaria
- Organizada, Coordinada
- Sostenida
- Integral

El Consejo Vecinal Local de Salud es el espacio que la comunidad tiene a su disposición para participar en la protección de su derecho a la salud.

Producida la creación del nuevo partido surgió una de sus primeras ordenanzas, **INDIO SANO**, que es de la gente del Municipio de Punta Indio. Ellos son los autores. Yo solo interpreté técnicamente sus deseos y puse palabras, las suyas.

Ordenanza de Creación del Sistema Municipal de Salud Pública Universal “Indio Sano” del Partido de Punta Indio

Tuve el honor de escribirla. Incluye fragmentos: *Abril de 1996.*

VISTO

... La potencia creadora de la comunidad del nuevo partido de Punta Indio...

...La convergencia de los intereses sectoriales representados en las JORNADAS PROGRAMÁTICAS PARA EL NUEVO MUNICIPIO...

... La creación posterior de los Consejos locales de Salud y Política Social y su correlato Federal, representantes genuinos del deseo inconsciente de una salud justa y universal...

... La elaboración por este Consejo del SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA INDIO SANO.... expresado en el DOCUMENTO DE PIPINAS luego de un trabajo arduo y consensuado unánimemente por representantes de todas las localidades...

... La inusual adhesión de los ciudadanos de aquellas localidades en donde se han iniciado alguno de sus subprogramas...

CONSIDERANDO

... La salud como un bien social impostergable, pilar de una sociedad justa ... La seguridad de la sabiduría de nuestro pueblo.

... La necesidad imperiosa de respetar nuestra identidad regional...

... Que la familia, como unidad celular básica de las comunidades debe ser la depositaria inicial de la salud...

...Que debemos priorizar la humanización del acto médico, la salud sobre la enfermedad, la vida sobre la muerte,

... La promoción, la prevención y la anticipación a la rehabilitación...

... Que debemos transformar lenta pero progresivamente el concepto actual limitador de la salud, para educar y educarse de la comunidad y a los efectores en un contenido ampliado de la misma, de acuerdo a los postulados del sistema...

... Que, finalmente, los pueblos rara vez se equi-

equitativa, un derecho, de tantos. Un ejemplo a imitar, con ese paradigma, en educación, trabajo seguridad, desarrollo social, cultura, turismo, etc.

Algunos aspectos normativos de la Ordenanza

Esquema de funcionalización del trabajo en un Municipio de 10.000 habitantes.

Para 10.000 Personas

- 25 Agentes Socio Sanitarios (1 cada 100 familias de 4 personas cada una) referenciados con
- 5 Unidades familiares con 1 médico Familiar y 1 enfermera cada 500 familias de 4 personas cada una) referenciados con
- equipo de Salud Familiar interdisciplinario cada 2500 familias de 4 personas cada una referenciados con
- 1 hospital Municipal, regional o Zonal cada 50.000 personas.
- Población nominal
- La familia y la comunidad con agentes socio sanitarios como FIGURA.

La salud desde el pueblo Un modelo posible: La construcción comunitaria de la salud

Consolidar la idea de la gobernabilidad, la participación comunitaria y la de las Organizaciones No Gubernamentales, constituidas en partercipes y auditoras de la sustentabilidad.

En aquellos escenarios donde los hechos son visibles, pueden ser regulados por el gobierno y evaluados por las organizaciones de la sociedad civil, generando sólidas redes de cooperación, solidaridad y capital social. El ámbito ideal para su ejecución es el Sistema Municipal.

Apuestas Estratégicas

La primera será la articulación, sinergia, coherencia, congruencia y adhesividad de las asociaciones civiles que trabajan en este escenario con la regulación y supervisión del estado Municipal.

La segunda será aquella de generar una Administración Estratégica del Desarrollo Humano.

La tercera la de instalar la equidad como idea guión en la Agenda Pública Municipal, con énfasis en los Grupos de Riesgo.

La Cuarta intentará re jerarquizar el rol del go-

bierno Municipal, con un horizonte optimista, considerando las peculiaridades de esta comarca, su historia, las instituciones y sus Academias y su perfil de liderazgo y extensión en el Universo Provincial y Nacional

La Programación Local Participativa (PLP) priorita el concepto de salud y enfermedad como una construcción social, cuyos ejes son la Promoción de la Salud, la participación Social y un proceso integral, integrado y continuo.

La PLP incluye como actores a las familias, las Instituciones y Organizaciones Comunitarias y al Equipo de Salud.

El eje del proyecto es la familia.

Sus Momentos son:

- Asignación de la Población.
- Diagnóstico de Salud.
- Programación según grupos etarios
- Monitoreo y Evaluación.
- RED DE PROGRAMACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA
- RED de Referencia y contra referencia
- CICLO VITAL FAMILIAR E HISTORIA DE VIDA.
 - Salud del Niño
 - Salud de la Mujer y del hombre
 - Salud de Adolescentes
 - Salud de los mayores de 60 años.
- Escenarios
 - Hospital Local
 - CENTROS DE SALUD
 - FAMILIAS
 - ONG
 - Comedores
 - Promotores de salud
 - Escuelas
- Descentralización. Monitoreo y Evaluación.

Este modelo presenta cuatro niveles

- La familia
- La Comunidad y sus organizaciones
- El Centro de Salud
- El Hospital Local de Referencia

Actividades con una modalidad propia

- Descentralización operativa
- Especialización funcional por niveles

- Participación comunitaria en promoción, cuidado y recuperación de su salud, con un enfoque de riesgo para facilitar la equidad en las prestaciones

Requiere para sostenerse y poder lograr sus objetivos

- Relación coordinada entre niveles,
- Supervisión,
- Capacitación continua en servicio,
- Monitoría y participación social.

Es un modelo de atención a la familia. Para esto, se debe:

- Aumentar considerablemente la cobertura de la población del área programática
- Implementar una red de servicios coordinada y eficiente,
- Incluir la participación comunitaria,
- Planificar las acciones en terreno,
- Normatizar las acciones de salud y los procedimientos administrativos necesarios,
- el uso de registros unificados (historia clínica informatizada, carné perinatal, curvas de crecimiento y desarrollo, hoja de referencia y contra referencia, fichero dinámico, etc.).

Se proponen cuatro años de ejecución a fin de transformar el actual modelo de atención.

Las actividades programáticas están enunciadas por criterio cronológico o mejor por ciclos de vida (embarazo, parto y puerperio, niñez, adolescencia, adultos, ancianos), como actividades de promoción de la salud (crecimiento y desarrollo, lactancia materna, inmunizaciones), y de prevención del daño (morbilidad y mortalidad prevalente).

La línea de base para el distrito al comienzo del plan:

- Índice de Desarrollo Humano.
- Tendencias del Índice de Desarrollo humano.
- Pobreza humana y de Ingresos.
- Tendencias Demográficas.
- Compromiso con la salud: acceso, servicios y recursos.
- Principales crisis y problemas de salud.
- Sobrevivencia. Desnutrición
- Compromiso con la educación: Gasto público.

- Alfabetización y matriculación.
- Tecnología: Difusión y creación.
- Desempeño económico.
- Desigualdad de Ingreso y consumo

En un escenario a mediano y largo plazo se propone dar respuesta a tres lineamientos principales:

- ✓ El primero tiene como principal desafío la disminución de la morbi-mortalidad general con énfasis en el área materno infante juvenil.
- ✓ El segundo, la necesidad de refundar un área que con criterios de eficiencia y eficacia permita llevar adelante estrategias consensuadas que den respuesta y solución al primer desafío.
- ✓ El tercero pretende la construcción de salud con la participación activa de la comunidad.

Lineamientos iniciales

- ✓ Confección del Plan estratégico y de la reingeniería del Modelo Organizacional.
- ✓ La Atención Primaria de la Salud y la participación comunitaria como tema prioritario de la Agenda Pública con énfasis en la Maternidad, la infancia y la adolescencia, con la familia como eje.
- ✓ Modelo Integral de relación con las áreas de Integración programática.
- ✓ Fortalecimiento de la programación y planificación local.
- ✓ Reducción de la morbi-mortalidad general por causas evitables
- ✓ Mejoría de los Sistemas de Información, del sistema presupuestario, de monitoreo y de control de gestión.

Los números del Indio Sano a los 5 años de su implementación

El partido de Punta Indio tiene 10.000 habitantes.

El 80 % vive en el área urbana.

El 12,1% de la Población es NBI.

La tasa de desempleo es del 14 % y la de Subempleo del 4,2%.

Se realizan más de 5 controles del embarazo y 9 consultas en el primer año de vida. La inmunización de la población cumplió con creces los objetivos del Plan original ("Indio Sano, una

Construcción comunitaria de la salud”).

El 8% de la población carece de agua potable y el 11 % de cloacas.

El Sistema de Salud Municipal atiende el 80% de los problemas de Salud y Enfermedad de la Población.

La tasa de mortalidad infantil es del 5,2‰.

El perfil epidemiológico marca que la consulta prevalente en Pediatría y en Clínica Médica es el control de salud (30%).

El 48% de las consultas son preventivas y el 52% asistenciales.

El Sistema de Salud atiende 45.000 pacientes/año.

El Sistema triplicó en 5 años la demanda: (15.000 / 45.000).

El promedio es de 4,5 consultas por habitante y por año.

El 20 % del presupuesto es de Política Social y Salud.

La atención y el tratamiento son universales y absolutamente gratuitos.

El Sistema es en red, nominado, basado en la APS, integrado al Subsector Público.

Tiene un sólido Marco Legal y un claro Marco Conceptual.

Goza de un fuerte aval del Ejecutivo y del Consejo Deliberante.

Ha logrado el consenso de una amplia franja poblacional a lo largo de su implementación.

Los Consejos Vecinales y Federales de Salud han surcado por distintos momentos.

Fortalezas del Sistema

-Permanencia del Sistema luego de 5 años de implementado y claras evidencias de pertenencia en la comunidad, a pesar de encontrarse en un estadio aún inicial de su planificación original.

-Resistencia a las dificultades coyunturales severas a las que se expuso en estos años.

-Consenso de los decisores políticos del oficialismo y de la oposición, en virtud del apoyo masivo de la población.

-Mejoría evidente, visible, cuantificable, de los servicios en salud del estado Municipal.

-Federalización de la oferta sanitaria, con consiguiente mejoría de la equidad en ámbitos y escenarios históricamente olvidados.

-Mejora de las condiciones socio sanitarias de la población del nuevo distrito en correlato cau-

sal con las políticas del área y notable diferencia con Municipios del resto de la región, la provincia y del país.

-Decisión del Intendente de Profundizar la filosofía del Sistema.

-Adhesiones políticas y académicas múltiples a la singularidad del proceso.

-Relativa eficiencia sanitaria en comparación al contexto.

-Concepción progresista de la Salud por el Ejecutivo Municipal, hegemonía política en los últimos años y fuerte decisión de implementar el programa que surge de una intensa adhesión comunitaria, peligrosamente diluida en la proximidad, por el advenimiento de actores, estrategias y escenarios no involucrados en el Plan fundacional.

Testimonios ficticiales de una las pediatras que se incorporó al proyecto, Camila *(claro que lo real y lo ficcional se confunden. Y que las narraciones son el producto de las vivencias).*

Empiezo una historia limítrofe entre la realidad y la ficción.

Una pediatra que luego de su residencia comienza a desarrollar su profesión en un Municipio de 10.000 habitantes. El micro era incómodo, sin calefacción y con los asientos rotos. Era el único servicio para llegar, dado que la línea ferroviaria había sido levantada el 31 de mayo de 1978, en la oscura época del Proceso Militar. Camila había terminado su Residencia de Pediatría y decidió radicarse en la ciudad capital de ese municipio de 10.000 habitantes, Verónica.

El claroscuro de las luces de los automóviles de la ruta, incendiando la ventanilla del micro, le impedían conciliar el sueño. Se sentía rara, con una mezcla no equilibrada de seguridad por su excelente formación profesional y de ansiedad por anticipar algunas de las aristas de su nuevo rol de pediatra en una comunidad donde funciona un sistema de salud diseñado por la comunidad participando.

Reconocía que su capacitación estaba centrada en la enfermedad, dado que su escenario de formación durante 5 años fue un Hospital de la máxima complejidad, con todos los servicios y referentes necesarios. Siete años en la Facultad y cinco en el Hospital. ¡12 años de estudio

dentro de las paredes de las cátedras y las salas; Ahora el escenario sería distinto. Los Centros de Atención Primaria del Municipio y un hospital de mínima complejidad. La comunidad participando, las formas frecuentes de presentación de las enfermedades prevalentes. Nada de respiradores, antibióticos de 3° generación, sin neuro imágenes, sin complejidad. Ahora el protagonista principal sería la salud, la promoción, la prevención, la educación comunitaria.

El ómnibus disminuye la velocidad, dobla hacia la izquierda e ingresa al acceso de su nuevo lugar y su nueva historia. En ese instante fugaz pero profundo que antecede a la visión premonitoria del futuro cercano una “lluvia de ideas” “moja” de una transpiración pegajosa e incómoda a Camila. Se le ocurre, preguntarse: ¿Seré la pediatra que necesita esta comunidad? Recuerda la clase en la Cátedra de Pediatría: *...“Solo el 10% de los Residentes de Pediatría harán una especialidad y aún en las ciudades trabajarán de clínicos pediatras”...* ¿Qué, cómo, donde, cuando, porqué, para que capacitarse? *“Los ejes son la clínica, la historia clínica, la relación médico paciente, el análisis de problemas y evidencias, el análisis de los perfiles epidemiológicos y las prioridades sociales”...* *“...Hay que orientar los programas a problemas Comunitarios, a los problemas prevalentes y hacia los problemas regionales...”* ¿Cómo será este Municipio rural de la pampa deprimida del Salado? Ahora debo Gestionar, asistir y planificar la Salud Materno Infantil del Municipio. El apunte decía que debo confeccionar una Tabla de Prioridades Sociales y averiguar acerca del Perfil Epidemiológico de la comarca. (Epidemiología clínica). ¿Cuáles serán las 10 causas más frecuentes de consulta? ¿Habrà Programa de Salud Escolar? ¿Cómo hago para Planificar la Educación Comunitaria? Los Consejos Vecinales de Salud y el Programa de Salud del Municipio lo tienen desarrollado hace años. ¿Quién me facilitará el diagnóstico inicial de salud materno infantil? Me pregunto, ¿cuántos menores de 20 años habitan el partido? ¿Cómo están distribuidos según grupos de edad? ¿Cuántos Recién nacidos hay por año en el Municipio? ¿Cuál es la

Tasa de mortalidad Infantil de la zona? ¿En qué momento de su vida se mueren? ¿Se mueren uniformemente en las diferentes áreas del Municipio? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de RN prematuros hay en la región? ¿Y de RN de Bajo Peso al nacer? ¿Qué razón de Mortalidad Materna hay en la zona? ¿Cuántas madres son menores de 20 años? ¿Cuántas madres son analfabetas? ¿Cuántos abortos se estiman por año? ¿Se realiza control adecuado del embarazo? ¿Hay Maternidades con Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales? ¿Hay Unidades de Cuidados Intensivos neonatales adecuadas? ¿Las embarazadas están nominalizadas? ¿Hay un equipo de salud organizado? ¿Hay un sistema de atención por cuidados progresivos? ¿Hay CAPS integrados en Sistema? ¿Se desarrolla la estrategia de Atención Primaria de la Salud? ¿Hay participación Comunitaria en las acciones de salud, desarrollo social y, educación? ¿Hay articulación interdisciplinaria? ¿Hay articulación intersectorial? ¿Hay desarrollo de Programas de Escuelas para la salud? ¿Hay acceso de toda la población? ¿Hay referencia, contra referencia e Historia única de salud en el Área ambulatoria y hospitalaria? ¿Hay ligas comunitarias de Lactancia materna? ¿Hay un proyecto de Promoción y extensión de la Lactancia Materna? ¿Está toda la población vacunada adecuadamente? ¿Cuánto dura la lactancia promedio en la zona? ¿Los controles promedios de los lactantes y los niños hasta la edad escolar son los necesarios? ¿Hay guarderías? ¿Hay programas de alimentación saludable en las escuelas? ¿El pueblo tiene plazas, club, centros recreativos y deportivos? ¿El medio ambiente es saludable? ¿Hay recolección adecuada de basura? ¿Hay mataderos o frigoríficos? ¿Hay control bromatológico en la comunidad? ¿Toda la población tiene agua potable y cloacas? ¿El aire está contaminado? ¿Las aguas están contaminadas? ¿Las tierras padecen organofosforados o glicero fosforados? ¿Hay cianuros en la zona? ¿Arsenicismo? ¿Hay colilargos en la zona? ¿Leptospirosis? ¿Hay vinchucas infectadas? ¿Ofidismo, alacranes? ¿Es zona de tránsito del dengue? ¿Larvas migrans visceralis? ¿Ganado ovino, caprino? ¿Hidatidosis? ¿Hay poblaciones golondrina? ¿Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión sexual? ¿Casos de HIV? ¿Hay pueblos

originarios? ¿Adicciones? ¿Rutas cercanas? ¿Cuáles son las condiciones habitacionales del pueblo? ¿Hay planificación urbanística? ¿Cómo es el clima de la zona? ¿Hay catástrofes naturales habitualmente? ¿Inundaciones? ¿Las familias tienen trabajo adecuado? ¿Hay repitencia y abandono escolar pronunciado? ¿Es una comunidad multiétnica? ¿Los niños y las niñas trabajan? ¿Los adolescentes trabajan o estudian? ¿Toda la población, incluida la infantil, está nominada? ¿Hay incidencia elevada de suicidios? ¿Hay violencia de género? ¿Hay niños en situación de calle? ¿Qué porcentaje de la población infantil tiene discapacidad? ¿Hay articulación Municipal de los Programas verticales de Provincia y Nación? ¿El sistema Municipal de Salud tiene un Vademécum Propio? ¿Hay relación entre los efectores del primer nivel de atención y los de máxima complejidad? ¿Hay sistema planificado de derivación? ¿El Sistema Municipal de Salud tiene recursos propios para la derivación a Centros de Mayor de Complejidad. ¿El Sistema Municipal de Salud tiene Ordenanza de regulación del mismo? ¿Qué % del Presupuesto se utiliza en acciones de APS? ¿El Sistema Municipal de Salud tiene carrera de salud Municipal? ¿El Capital humano es el adecuado? ¿Son full Time? ¿El Sistema Municipal articula con el Subsector Privado y el de las Obras Sociales? ¿Hay participación Comunitaria Organizada en el Concejo Deliberante en lo que concierne a Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación? ¿Hay control social de la consecución de las Metas en Salud? ¿Se han evaluado las prioridades sociales en salud? ¿Se ha evaluado el perfil epidemiológico regional? ¿Hay formas de Educación Permanente en Salud?

Desde el micro se iluminaba la silueta de San Martín en la prolija Plaza de la pequeña ciudad. Pero la lluvia, de ideas, no cedía, aún ante la inminencia de la llegada.

¿Cómo era aquello de que el pediatra debe ejercer funciones de abogacía, conceptualizando al niño como sujeto de derecho? ¿Cómo se cumplen los Derechos del Niño? ¿Dónde se deben cumplir? ¿Qué dice La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)? ¿Cuáles son los Derechos del Niño? ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de esos derechos?

¿Cuáles son los instrumentos legales para su cumplimiento? ¿Cuáles son las necesidades elementales de los niños? ¿Cuáles son los 10 Principios de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cuál es el diagnóstico de situación en nuestro país?

El ómnibus pasa por uno de los Centros de Atención Primaria de Salud del Distrito.

Son las 20.35 hs de un día de semana y está abierto. Imagina, Camila, su práctica de la Clínica Pediátrica. ¿Cuáles serán los problemas prevalentes y sus escenarios de atención? ¿Cuáles serán las consultas frecuentes, las no frecuentes? ¿Y en el Hospital de la Comunidad? ¿En la Emergencia, en la sala, en la Maternidad, en el Consultorio Externo?

En el teórico se afirmaba que 20 motivos de consulta explican el 82% de los problemas de enfermedad en el niño.

Camila trajo el libro de las 100 situaciones problemas en el área asistencial, pero con su forma de comienzo habitual, desde los signos y síntomas guiones.

¿Cuáles serán las causas de Morbimortalidad en Punta Indio? ¿Tendrá el Municipio una red para la derivación de las situaciones que requieran internación?

En su último e interminable giro, el micro pasa por la Escuela más grande del distrito. ¿Cómo era eso de la visión ampliada y la extensión de la salud infantil?

A las 21 hs de un frío día del invierno del sur Camila llega a su nueva historia.

La esperaban los miembros del Consejo Federal de Salud, que la homenajearon con un asado en el Centro de Jubilados.

Allí la tranquilizaron y le pusieron un buen “paraguas” para su “lluvia de ideas”

Consensuaron, luego de los postres exquisitos de las mujeres del lugar.

En Punta indio nacen entre 150 y 170 recién nacidos por año.

Si hacemos la campaña de Promoción y Prevención no tendremos mayores problemas.

Los controles de cada embarazada están asegurados.

La Maternidad distrital cumple con las CONE.

Los embarazos de alto riesgo son derivados oportunamente a los Centros que tienen convenio con el Municipio. Las Cardiopatías Congéni-

tas con diagnóstico Antenatal, también.

El secreto es la Promoción y la Prevención.

El Consejo, los Agentes Sanitarios, las obstétricas, los ficheros dinámicos y el Sistema del Médico y Enfermeras de Familia con nominalización, fundamentales.

En Punta Indio no mueren los RN con muertes evitables.

Dice Camila, entonces lo que tengo que hacer es:

Detectar las formas de inicio de las afecciones frecuente, las prevalentes, como dicen los del Consejo.

Prevenir el RN Prematuro y el bajo Peso.

Anticipar el diagnóstico de las Cardiopatías Congénitas.

Evitar la Bronquiolitis, promocionar de acuerdo a las evidencias.

Anticipar las neumonías.

Vacunar para evitar las meningitis en las guarderías.

Hablar de la teta.

Del medio ambiente.

Luchar para que los niños no trabajen.

Gestionar agua segura y cloacas.

Alimentación saludable. Control del Crecimiento y desarrollo.

Y la clínica.

Anticipación. Lectura de las familias, de los signos y síntomas guiones.

De la familia y de la madre como nichos integrales.

Acceso, anticipación, igualdad de oportunidades, equidad.

Generar mapas de riesgo sanitario.

Anticipar las enfermedades emergentes de la zona. Colilargos, dengue, botulismo, coqueluche, TBC en los "golondrinas", enfermedades de Transmisión sexual (ETS).

Estar atenta a las corrientes migratorias.

Y pensar en el niño sano, integral, que juega, corre, aprende, no trabaja y vive en una casa y un medio ambiente seguro.

A las guarderías, los jardines y las escuelas. Con el concurso y la sinergia del Consejo Escolar del Municipio. Con la ayuda del vecino y los agentes sanitarios.

Priorizar la salud escolar y los adolescentes, los olvidados de siempre.

Los que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, que en nuestro país llegan al 20%.



Y las adicciones, y los suicidios y los traumas.
Hay que ir a las cooperativas y transformar a los sindicatos, los profesores de educación física y a los maestros en agentes de salud.

Y los accidentes en la vía pública y en las rutas cercanas. Y la nocturnidad.

Las fuerzas de seguridad, los policías y los bomberos son actores protagonistas del hecho sanitario.

Y las ETS. Y el embarazo adolescente Y el aborto clandestino. Y el hijo no deseado.

Y la educación.

Para nosotros estos problemas son complejos. Están atravesados por una multiplicidad de variables.

De Situaciones. Y de nombres.

Claro que con la Nominalización y las familias a cargo virtualmente se acaban las consultas espontáneas, sin nombre, ni apellido, lugar de residencia y dirección, ni seguimiento, como en los consultorios externos o de emergencias de los grandes hospitales.

En estos pueblos pequeños de grandes espíritus las familias y sus hijos tienen nombre, historia única y médico único, que desarrolla una atención integral con la direccionalidad del crecimiento y desarrollo, la prevención, el estímulo a las prácticas claves de salud y el adecuado y oportuno tratamiento de las afecciones prevalentes en la infancia, sin obviar la rápida reparación de las afecciones crónicas o secuelas.

Historia clínica como herramienta, del Vademécum Municipal y del Laboratorio Municipal Básico, lo que se sintetizará en las Normas Municipales de Tratamiento.

Esa noche logró dormir tranquila en la casita cálida que le alquilo el Municipio.

Testimonios del equipo de salud

Testimonios de los Trabajadores de Atención Esencial del Indio Sano, Coordinados en todo el Municipio por la Lic. Cristina Kairuz, Educadora Sanitaria del Proyecto.

... *“Doña Beba, esposa de Juan Pérez, estaba en el 5º mes de embarazo. Multípara de 7 hijos. Ella ignoraba “eso” de La Planificación Familiar y “lo” del control del embarazo. Sus partos habían sido atendidos por una comadrona que vivía a 2 km del puesto del campo. Le explicamos y le entregamos material educativo sanitario elaborado por todo el equipo de salud de los Consejos Vecinales sobre Planificación Familiar y Control del embarazo. Lo leímos y le explicamos la importancia. Quedamos que en la próxima visita iríamos con el Médico y la Enfermera de familia para realizar un control familiar y a vacunar a sus 7 hijos, deficitariamente inmunizados”...* Argentina Ardiles. *Enfermera de Familia en Punta Indio.*

... *“Trabajando en zona rural, con gente de escasos recursos, participando a pleno en la atención del enfermo”...*

... *“No se imaginan que paso horas buscando fichas de los niños no vacunados, o preparando gasa, o haciendo planillas para poder visitar a los enfermos, principalmente a los ancianos que no pueden llegar a la unidad sanitaria...”*

“... Para que aunque sea en mi vejez pueda ver realizado este sueño acariciado y luchado de un Punta Indio de habitantes sanos...”

Será necesario retornar en estas épocas de globalización, dengue y COVID 19 a escuchar la sabiduría de los pueblos silentes.

“Indio sano es el producto del imaginario colectivo. No tiene patrón, patente ni autor. Tiene potencia. Solo persistirá si no se extingue la llama de la participación comunitaria” Juan Reichenbach.

Bibliografía

- Colabianchi Luis, Reichenbach Juan. *Indio sano, una construcción comunitaria de la salud*. Buenos Aires: Del sur ediciones, 1996.

EL ARTE DE LA SALUD. CONVERSATORIO SIN TIEMPOS



PROF. DR. JUAN REICHENBACH

Sumario

Recopilación de vivencias, poesías, imágenes, conceptos, ideas y algo más, acerca de la salud integral de los niños de todos los mundos.

Fue un día de estos. En un lugar sin tiempos ni apuros. Me sorprendió la idea. Me atemorice por la talla de los participantes. Por la diversidad de las disciplinas. Por un encuentro on line desde quien sabe dónde. Con terminales sin wifi ni hardware adecuado. Claro que el tema me atrapó: LA SALUD INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE TODOS LOS TIEMPOS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHO Y DE GÉNERO.

El doctor René Gerónimo Favalaro me contó que:

“Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo”.

“En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad”.

Desde “Recuerdos de un médico rural” agrega: *“En estos días en que tanto hablamos de la Universidad, yo creo que hemos perdido el derrotero en cuanto a prioridades en la enseñanza... La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad”.*

“Estoy seguro de que, en el futuro, se harán menos angioplastias y menos cirugías de revascularización. La prevención, junto con los adelantos de la biología molecular relacionados con la genética, permitirán disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Y eso tiene que ver con los Programas de Grado”.

Sostuvo además que *“todo universitario debe comprometerse con la sociedad de su tiempo, quisiera ser recordado como docente más que como cirujano”.*

Vicente Climent, pionero de la neonatología mundial, egresado y profesor de la Facultad de Medicina de la UNLP nos contó que: *“todos los niños, tienen el derecho a la salud y a la atención de máxima calidad, independientemente de su clase social” y que “la actividad asistencial y la docente son inseparables”.*

Luis García Azzarini recordó *“mis grandes maestros fueron los niños de la Casa Cuna y los estudiantes”.*

Noel Sbarra expresó *“escuchemos a la gente, a los estudiantes y decidimos”.*

El Profesor Bernardo Manzino nos dijo *“Los alumnos irán aprendiendo al lado del docente la norma de conducta que es consustancial con el ejercicio de nuestra profesión: el trato afectuoso y tolerante con los enfermos y la ética frente a los colegas”.*

Me resultaba difícil coordinar este conversatorio policromático. Creí que el tema se estaba dirigiendo hacia la educación en salud, uno de los aspectos programados, cuando irrumpió Antón Chéjov, recordando su infancia de hace casi dos siglos:

“La inevitable mirada al terrible presente y al

incierto futuro de todos los niños desamparados que evoco, dijo, fue por mi padecida. De pequeño escapaba de las palizas de mi padre con la anuencia de mi madre. En "Los campesinos" rescato varios niños de mi realidad, evoco la miseria y la resignación del pueblo ruso. Los niños representan un papel importante, como víctimas inocentes de las grandes injusticias y miserias sociales. Y presentó a Vanka, niño de nueve años, huérfano en una carta que escribe a su abuelo y en la que le cuenta sus amarguras con pueril desesperación: - No tengo papá ni mamá; sólo te tengo a ti. Ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos, por haberme dormido arrullando a su nene. El otro día, la maestra me mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola; entonces la maestra cogió la sardina y me dio con ella en la cara. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan; para comer, unas gachas de alforfón; para cenar, otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa; ni siquiera una taza de té". - "Duermo en el portal y paso mucho frío; además, tengo que arrullar al nene, que no me deja dormir con sus gritos... Abuelito, sé bueno, sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida..."

Se conectó Dostowieski.

Fui el segundo de los siete hijos del matrimonio de Mijaíl Dostoievski y María Fiódorovna. Un padre autoritario, médico del hospital para pobres Mariinski en Moscú, y una madre vista por sus hijos como un refugio de amor y protección marcaron mi ambiente familiar en la infancia. La temprana muerte de mi madre por tuberculosis sumió a mi padre en la depresión y el alcoholismo

Un buen recuerdo puede colmar toda una vida de felicidad, dijo para empezar. En Los hermanos Karamázov abogó por un cristianismo en el que la redención y resurrección del ser humano pudiera ocurrir en la tierra cuando los hijos redimieran con sus acciones los pecados de sus padres; de este modo se lograría la unión de la raza humana en una familia universal.

- En la tierra hay una gran cantidad de horribles sufrimientos. Es terrible lo mucho que el hombre tiene que soportar en la tierra. Es terrible la enorme desdicha que ahí se le depara.

La tierra está inundada de las lágrimas de los hombres.

- El sufrimiento lo encontramos en su manifestación más poderosa y arrebatadora en los niños. Los adultos han caído en pecado, están unidos por la solidaridad en el pecado, y su sufrimiento, al menos en parte, puede concebirse como castigo o bien como expiación por sus pecados. Pero los niños están aún libres de pecado, de modo que no se puede aducir esta razón ni tampoco se ofrece explicación alguna.

- Yo considero el sufrimiento de los niños como el argumento de más peso en favor del ateísmo.

- Si es necesario que todos sufran para comprar con los sufrimientos la armonía eterna, ¿qué tienen que ver los niños con ello?"

Las causas más importantes del sufrimiento son la humillación, la vejación y la injusticia, la conmiseración hacia el sufrimiento y la muerte de hombres queridos, la desesperación del alma que ya no puede creer en el sentido del ser, así como la imposibilidad de saciar el anhelo espiritual que vive en nosotros. Cuán grande puede ser ya sólo la compasión por un ser querido lo testimonia de modo arrebatador el sufrimiento de las madres por los hijos perdidos.

Profundas palabras las de Fiodor. Tristes.

Por suerte la alegría de vivir llegó con las palabras de Pablo Neruda, que agradeció la invitación a los organizadores y expresó:

- En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir.

El niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivió en él y que le hará mucha falta. He edificado mi casa también como un juguete y juego con ella de la mañana a la noche..., dijo para empezar.

Desde "Confieso que he vivido":

- Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia.

- Mi niñez, precaria en lo material, y sin embargo plena en afectos, transcurre inmersa en la voluptuosidad del follaje propio del sur de Chile. La lluvia, la tierra, la selva y el agua, serán elementos siempre presentes en mi obra.

- Mi vida fue una larga peregrinación que siempre da vueltas, que siempre retorna al bosque austral, a la selva perdida.

- La poesía es siempre un acto de paz. El poeta nace de la paz como el pan nace de la harina.

Dijo: -Los poetas, como los niños, tenemos derecho a ser felices, sobre la base de que estamos

plenamente unidos a nuestros pueblos y a la lucha por su felicidad, y agrega, pero el caso es que soy feliz por dentro. Tengo una conciencia tranquila y una inteligencia intranquila.

Sencillo, tranquilo y locuaz apareció Mario Benedetti desde un zoom armado en una nube de Montevideo y desde “El niño cinco mil millones”.

- En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países, en ese día eligieron al azar un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto.

- Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil Millones no fue homenajeadado ni filmado ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer ya tenía hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, éstos tocaron tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de camellos o de vacas. También con el esqueleto del niño 4.999.999.999.

- El verdadero niño Cinco Mil Millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar superpoblado.

Evidentemente el conversatorio se estaba tiñendo de poesías y ahí intuí que el arte forma parte de la integralidad de la salud, así que no atiné a interrumpir a los siguientes conectados.

Salud y poesía sonaban raro pero armónicos.

Nicolás Guillén recitó desde un cumulus en Camaguey:

"Cuando yo vine a este mundo,/nadie me estaba esperando;/así mi dolor profundo se me alivia caminando,/pues cuando vine a este mundo,/te digo,/nadie me estaba esperando"...

Fue el turno de Astor Piazzolla, el poeta uruguayo-argentino Horacio Ferrer y del polaco Roberto Goyeneche con sus “Chiquilín de Bachín”.

Piazzolla dijo: El tema trata de un chico de la calle que vende flores en los restaurantes de la zona de teatros de Buenos Aires, ubicados en la avenida Corrientes. Bachín era un bodegón

ubicado sobre la vereda de la calle Sarmiento. Lo invitamos a Pablo Alberto González, el niño vendedor de flores, de 11 años, el protagonista.

Por las noches cara sucia/de angelito con bluyín/vende rosas en las mesas/del boliche de Bachín./...¡Chiquilín!./dame un ramo de voz,/así salgo a vender/mis vergüenzas en flor.

Desde “Plegaria para un niño dormido”, Luis Alberto Spinetta, agregó:

...Déjenlo que siga soñando felicidad!/Plegaría para un niño dormido,

quizás tenga flores en su ombligo/y además, en sus dedos que se vuelven pan,/barcos de papel sin altamar...

León Gieco y Antonio Tarrago Roos desde sus pc en tierra recordaron: “Canción para Carito”, un chamamé de gran contenido social....*Sentado solo en un banco en la ciudad/Con tu mirada recordando el litoral/Tu suerte quiso estar partida/ Mitad verdad, mitad mentira/como esperanza de los pobres prometida...*

El Chango Spaciuk interpretó Tareferos de mi pago. *-Terminó la zafra y nada ha cambiado seguís igual, con tu karaya reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal.*

Era evidente que el conversatorio me había excedido. Me alegró la participación sin tiempos que me sorprendía. Por suerte ante el murmullo de un auditorio de pediatras aparecieron los sanitaristas.

Desde 1910, Gregorio Aráoz Alfaro nos recomienda a los médicos que *“no pierdan de vista jamás los altos fines sociales de nuestra ciencia y de nuestro arte, pues estamos destinados a servir a los demás antes que a nosotros mismos; que el bien público, el alivio de las sociedades que sufren y la preservación de la salud general deben ser nuestras primordiales preocupaciones”.*

Cuando todo parecía encaminado irrumpieron nuevamente los poetas, como si supieran que son más narrativos en la descripción de la enfermedad y la inequidad que el más excelso de los académicos.

Conectado desde el pueblo de Fuentevaqueros en Granada llegaron los espíritus de Federico García Lorca, desde 1936, año de su fallecimiento como víctima de la guerra civil española.

- En “Paisaje” evoqué una tarde de mi infancia, expresó centenario y transparente.

La tarde equivocada / se vistió de frío. / Detrás de los cristales turbios /, todos los niños ven

convertirse en pájaros / un árbol amarillo. / La tarde está tendida/a lo largo del río.

Y un rubor de manzana / tiembla en los tejadillos...

Pegadito nomás, un alma en zoom desde Sevilla en las postrimerías del siglo XIX. La de Antonio Machado en “Para niños y niñas... y otros seres curiosos”.

*Soñé que tú me llevabas/por una blanca vereda,/en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras, /hacia los montes azules,/una mañana serena.*

*Sentí tu mano en la mía, /tu mano de compañera,/tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,/ como una campana virgen/de un alba de primavera.*

¡Eran tu voz y tu mano, /en sueños, tan verdaderas!...

Vive, esperanza, ¡quién sabe /lo que se traga la tierra!...

Cerca, muy cerca, el micrófono de Miguel Hernández

He sido poeta de lenguaje transparente y de fuertes convicciones de igualdad para mi pueblo_ nos expresó. En la prisión escribí para mi hijo, Manolillo, “El potro oscuro”. Mi compañero de prisión, maestro, lo ilustró en papel higiénico.

...Una vez había un potro oscuro. Su nombre era Potro-Oscuro.

Siempre se llevaba a los niños y las niñas a la Gran Ciudad del Sueño.

Se los llevaba todas las noches. Todos los niños y las niñas querían montar sobre el Potro-Oscuro.

Una noche encontró a un niño. El niño dijo:...- ¡Deprisa, deprisa!, Potro-Oscuro, ve más deprisa.

Pero el Potro-Oscuro no podía ir deprisa. El Potro-Oscuro iba despacio, despacio, despacio.

Había llegado a la Gran ciudad del sueño. Los niños, el perro blanco, la gatita negra y la ardilla gris estaban dormidos.

Todos estaban dormidos al llegar el Potro Oscuro a la Gran Ciudad del Sueño...

A esta altura los poetas colmaron de letras a los niños, las niñas y los adolescentes. Y a los pediatras.

José Pedroni recitó:

...He intentado ser sencillo, humano, accesible por la claridad fraterna, religioso en la intimidad

o en el hogar, compañero de la naturaleza, cantor primitivo, honesto, revelador de un vitalismo de mundo cotidiano. Mi vida de niño campesino y pobre me permite alentar a todos los espíritus infantiles de la eternidad. No dejen de cumplir sus sueños....

En un inglés de campo y con traductor, Walt Whitman contó de su infancia pobre, feliz y rural en los orígenes de su país.

- No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

- Me celebro y me canto a mí mismo.

- Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano.

- Lo insignificante es tan importante como todo lo demás.

- Cuando doy, me doy a mí mismo.

- Lo que satisface al alma, es la verdad.

- La vida es lo poco que nos sobra de la muerte.

- Mira tan lejos como puedas, hay espacio ilimitado allá.

- Yo no hablo del principio y del fin. Jamás hubo otro principio que el de ahora, ni más juventud o vejez que las de ahora, Y nunca habrá otra perfección que la de ahora, ni más cielo o infierno que éstos de ahora.

- No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

- No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

A esta altura del encuentro noté que un grupo de conectados empezaron a irse de la reunión. Eran los de algunos colegios profesionales y los dueños de los sanatorios privados.

Llegó Ghandi.

- Nunca ojo por ojo porque todo el mundo acabará ciego.

- La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.

- La verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella. No hay camino hacia la paz, la paz es el camino.

- Hay suficiente agua para la vida humana pero no para la codicia humana.

Martin Luther King Jr, desde un Cyber de Memphis.

No usen la violencia como estrategia. Es una espiral descendente, que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, podéis matar al mentiroso, pero no podéis matar la mentira, ni restablecer la verdad.

Utilizando la violencia, podréis asesinar al rencoroso, pero no podréis matar el odio. De hecho, la violencia hace simplemente crecer el odio. Y esto continúa.

Devolver el odio por el odio multiplica al odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas.

He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. Pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral.

Esclareció que los niños y las mujeres eran los excluidos de un mundo de blanco, de hombres y de adultos.

Ana Frank desde una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam:

- Mi diario es un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie.

- Nunca más los niños como víctimas de las guerras de los adultos

Sayhueque, el último cacique de los mapuches. El “rey de las tierras del manzano salvaje” refiriéndose al maltrato de niños y mujeres en “La campaña del desierto” habitado.

- En los partes militares, se admite el secuestro de chicos, la matanza de prisioneros, la violación sistemática como arma de guerra. La prostitución forzada fomentada desde los mandos. Ejército atacó a sabiendas tolдерías vacías de hombres adultos porque estaban en otras partidas, con mujeres y chicos solos. Separaban a las mujeres de los varones, Les cambiaban el nombre a los niños, de tal manera que muchos saben que tienen ascendencia indígena pero no pueden reconstruir su historia familiar.

En “Irlandeses detrás de un gato”

- El colegio que presento era una institución de beneficencia, administrada por curas, donde todos los niños comparten carencias económicas y el mismo origen racial: una especie de igualación ante la pobreza, la orfandad, el infortunio o la sordidez de sus circunstancias personales. Y lo que impacta es que todos estos niños, os-

cura, misteriosamente, están llenos de soledad, resentimiento y furia. Estos no son niños privilegiados, sino que se han curtido en la mecánica del mundo desde el inicio, casi sin darse cuenta, haciéndose su propio camino con el esfuerzo de sus manos, y siguen soñando con madres o padres o sencillos milagros aunque parezcan condenados a destinos trágicos, dijo Rodolfo Walsh, en una referencia autobiográfica.

Roberto Arlt:

- Es la más autobiográfica de mis obras. La novela está situada en Flores, en los “barrios bajos” de Buenos Aires. El personaje protagonista y narrador, Silvio Astier es pobre y funda con otros dos adolescentes el «Club de los Caballeros de la Media Noche», que se dedica a pequeños robos en el barrio.

Desde “El niño proletario”, con una sutil ironía, Osvaldo Lamborghini expresa:

- Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la sangre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo, asistida por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor, entre vómitos que apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se emborracha con un vino más denso que la mugre de su miseria.

- Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en un hogar proletario.

- El padre borracho y siempre al borde de la desocupación, le pega a su niño con una cadena de pegar, y cuando le habla es sólo para inculcarle ideas asesinas.

Desde niño el niño proletario trabaja, saltando de tranvía en tranvía para vender sus periódicos.

En la escuela, que nunca termina, es diariamente humillado por sus compañeros ricos.

-En mi escuela teníamos a uno, a un niño proletario.

A esta altura del conversatorio era necesaria la presencia de las figuras de la salud.

En 1946 y desde la Secretaría de Salud Pública de la Nación, con rango de Ministerio, el Dr. Ramón Carrillo nos explica

“Es evidente que actualmente no puede haber Medicina sin Medicina Social y no puede haber

Medicina Social sin una política Social de Estado”.

“De que nos sirve que se acumulen riquezas en los bancos si los niños de los pueblos del interior andan desnudos por insuficiencia adquisitiva de sus padres y tienen que soportar así índices de mortalidad infantil medievales”.

“El problema sanitario debe radicarse en la unidad familiar y social; sobre ella inciden conjuntamente múltiples factores: el nivel económico social, el régimen de trabajo, los salarios, la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación”.

“Solo queda la posibilidad de optar por un régimen impositivo que se aproxime al ideal de justicia”.

“La suma de las cotizaciones y la carga de los riesgos se deben equilibrar en el conjunto de la colectividad por una compensación entre los más ricos y los más pobres”

“Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.”

“Debemos pensar que el enfermo es un hombre que es también un padre de familia, un individuo que trabaja y que sufre; y que todas esas circunstancias influyen, a veces, mucho más que una determinada cantidad de glucosa en la sangre. Así humanizaremos la medicina.”

“En una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad.”

“No puede haber política sanitaria sin política social.”

“De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.”

“Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas”.

Igual que Floreal Ferrara, otro de los olvidados. Locuaz y sonriente se explayó acerca de su visión de la salud manipulada.

La salud es la solución del conflicto. No tiene nada que ver con esa definición como “completo estado de bienestar físico mental y social” que utilizábamos en aquellas épocas, surgida de los organismos internacionales de salud. Este con-

cepto lo estudiamos epistemológicamente con Milcíades Peña, y nuestra definición se pelea con el estado de bienestar y el “estar bien”. Nuestra definición de salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Y por otro lado, estoy convencido de que siempre que uno hable de salud, no hay perspectiva de otra salud que aquella que construye el Estado. No hay perspectiva de creer en la salud privada. La salud privada es un negocio mercantil para los ricos que la pueden pagar.

Guillermo Rawson expresó con voz titubeante
- Los problemas sanitarios de los pobres no se resuelven excluyéndolos como policía sanitaria, sino creando obras de infraestructura sanitaria tales como agua potable, viviendas y saneamiento ambiental.

Carlos Alberto Alvarado desde Tilcara:

No hay otra forma que trabajar que casa por casa, persuadir y enseñar. Esto no se arregla ni con suero ni con terapia intensiva. La Medicina no es la enfermedad, es la salud.

Luis Morquio desde el Asilo de Expósitos y Huérfanos, Montevideo:

Les comunico que voy a eliminar el torno. No quiero que los niños sean abandonados en forma anónima. Además, propongo ayudar a las madres y evitar que abandonen a sus hijos. Ellas son las víctimas de una sociedad sin equidad.

Le llegó el turno a Carlos Juan Finlay, de prolija guayabera blanca, desde Camaguey,

Tengo la gloria de haber descubierto, y probado, que el mosquito Culex era el único agente transmisor de la fiebre amarilla, a pesar de que aún hoy la verdad frecuentemente se escribe confusa, porque los colegas del país imperialista me quisieron robar el descubrimiento.

Los monitores identificaron a Gregorio Aráoz Alfaro, desde Buenos Aires, desde su “Libro de las madres”:

-El mejor seguro de vida para los niños y el país son las madres.

-Recomiendo a los médicos que no pierdan de vista jamás los altos fines sociales de nuestra ciencia y de nuestro arte, pues estamos destinados a servir a los demás antes que a nosotros mismos

Desde 1928 Carlos Chagas agregó un concepto que generó exclamación entre los cyber escuchas:

-Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio, apunta un dedo hacia una población malnutrida que vive en malas condiciones; apunta hacia un problema económico y social, que a los gobernantes les produce tremenda desazón, pues es testimonio de incapacidad para resolver un problema tremendo.

Salvador Mazza,
Fuí acusado de desprestigiar a la Argentina por "inventar enfermedades donde no las había".

Cuando propuse quemar los ranchos en salvaguarda de la salubridad jujeña, los funcionarios a través de la prensa me tildaron de "desequilibrado mental y piromaníaco", porque, según ellos, quería pasar a la historia exterminando un insecto "inofensivo".

Sorprendió el último invitado de esta Sesión informática de conferencistas de siglos anteriores, el doctor Ernesto Guevara:

Empecé a viajar por América y la conocí entera. Por las condiciones en que viajé, primero como estudiante y después como médico, empecé a entrar en estrecho contacto con la miseria, con el hambre, con las enfermedades, con la incapacidad de curar a un hijo por la falta de medios, con el embrutecimiento que provocan el hambre y el castigo continuo, hasta hacer que para un padre perder a un hijo sea un accidente sin importancia, como sucede muchas veces en las clases golpeadas de nuestra patria americana. Y empecé a ver que había cosas, que en aquel momento, me parecieron casi tan importantes como ser un investigador famoso o como hacer algún aporte substancial a la ciencia médica: y era ayudar a esa gente. Comprendimos perfectamente que vale, pero millones de veces más, la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra.

José Pedroni quiso relacionar la salud con la maternidad y dejó estas letras llenas de ternura:

Maternidad (fragmento)

Mujer: en un silencio que me sabrá a ternura, durante nueve lunas crecerá tu cintura./Y en el mes de la siega tendrás color de espiga./Vestirás simplemente y andarás con fatiga./El hueco de tu almohada tendrá un olor

a nido./Y a vino derramado nuestro mantel tendido/Un día, un dulce día con manso sufrimiento,/te romperás cargada como una rama al viento./Y será el regocijo de besarte las manos./Y de hallar en el hijo/tu misma frente simple, tu boca, tu mirada./Y un poco de mis ojos, un poco, casi nada...

"Hay un niño en la calle", recitó otro de los invitados, el poeta mendocino Armando Tejada Gómez, recreando su dura infancia.

...A esta hora, exactamente,/hay un niño en la calle.

Cuando subo a la vida juntando la inocencia,/mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía/ como un vagón de carga

y saber que a esta hora mi madre está esperando,

quiero decir, la madre del niño innumerable/ que sale y nos pregunta con su rostro de madre: qué han hecho de la vida,/dónde pondré la sangre,

qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle...

...Cuando uno anda en los pueblos del país/o va en trenes por su geografía de silencio,

la patria/sale a mirar al hombre con los niños desnudos/y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre la espalda escandalosa de las grandes ciudades/nutriéndose de trigo, vides, cañaverales donde el azúcar sube como un junco en el aire,/uno encuentra la gente, los jornales escasos,una sorda tarea de madres con horarios/y padres silenciosos molidos en la fábricas,/hay días que uno andando de madrugada encuentra/la intemperie dormida con un niño en los brazos...

Apareció en el escenario Oliver Twist desde la segunda novela del inglés Charles Dickens, en los albores de la revolución industrial.

-Fui un niño huérfano que perdía papa y mama -Pasé mis primeros años en el orfanato con hambre. Luego fui enterrador, formé parte de una banda de chicos carteristas.

-En Londres conocí de cerca la pobreza, la suciedad o la delincuencia y la tristeza de la prostitución de mi amiga Nancy.

Luego conocí a Tom Sawyer que está aquí entre nosotros y al cual les presento:

-Yo crecí en Sur de los Estados Unidos en «St. Petersburg», una población de la costa del río Mississippi inspirada en Hannibal, donde nació mi padre literario Mark Twain, en las orillas de ese río, en el sur de Estados Unidos.- dijo Tom.-

- Viví con mi tía Polly y fui amigo de Huckleberry Finn, hijo del borracho de la ciudad.

Todos conocen mi historia, por lo que no los aburriré contando mis difíciles momentos.

- Quisimos estar con Oliver Twist para apoyarlos desde la eternidad.

- Hemos denunciado y sufrido las injusticias de un mundo inequitativo para los niños desde hace siglos.

Tarde y exhausto llegó León Felipe y expresó:
Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo, tan solo lo que he visto. Y he visto:

Que la cuna del hombre la mecen con cuentos...
Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos...

Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos...

Que los huesos del hombre los entierran con cuentos...

Y que el miedo del hombre...

Ha inventado todos los cuentos.

Yo sé muy pocas cosas, es verdad.

Pero me han dormido con todos los cuentos...

Y sé todos los cuentos...

- El Hombre es lo que importa. El Hombre ahí, desnudo bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia auestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia... La que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento.

¿Quién soy yo?

- Juanito, es de Pompeya o Villa Crespo. Ramona es la "milonguita", la "costurerita que dio aquel mal paso". Ella ya ha trascendido su barrio; está en Florida y en Corrientes y Esmeralda, nos cuenta Antonio Berni.

- El padre fue, tal vez, un porteño modelado por los tangos de Discépolo.

La madre era una resignada mujer del interior
- Ramona es un símbolo de las mujeres de las grandes ciudades que se prostituyen para sobrevivir. La mujer de las letras de tango.

- Los monstruos se refieren al universo fantástico del artista y a su conciencia del mal y del

horror.

Remiten a las pesadillas de Ramona Montiel y de Juanito Laguna y también a los horrores de la guerra.

- Yo a Juanito y a Ramona los hice precisamente en collage, con materiales de rezago, porque era el entorno en que ellos vivían. Les puse nombre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, marginados niños y humilladas mujeres; y los convertí en símbolo.

- Yo a Juanito Laguna lo veo y lo siento como el arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana, lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Para mí no es un individuo, una persona: es un personaje... En él están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle..."

- Juanito Laguna es el niño pobre de las grandes urbes latinoamericanas.

Representa a los chicos que viven en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o viviendas de chapa y cartón. Sus padres trabajan en fábricas o talleres, hacen changas para mantener a sus familias.

Sus madres trabajan en la costura o limpiando casas.

Llegó por la nave lateral Raúl Schurjin.

- Fuí un pintor y dibujante argentino que nació en Mendoza en 1907.

- Mis cuadros están inspirados en tipos del litoral, de ese litoral cuya larga costa le ha ofrecido motivos para las muy típicas series de "costeritas".

-El litoral santafecino me unió en abrazo el sentir de mi paleta con esas telas en las que quedaron todos los retratos, las naturalezas muertas, las estampas de la vida humilde y cotidiana... y también ellas, las costeritas, que aún esperan... por siempre esperan.

- Yo soy Carlos Alonso, un pintor, dibujante y grabador, representante de la corriente social del arte en mi país.

- Mi pintura alterna entre subjetividad y racionalidad, entre caos y orden, entre placer y disciplina. En mi obra están presentes, además, las heridas producidas por la dictadura militar, apostando por el compromiso político.

Brueghel, desde su plato de polenta, Goya y

Esteban Murillo desde sus niños hambrientos comiendo y robando frutos, adhirieron a esta actividad on line.

Claro que otros como John Lennon desde Mother Madre, *me tenías pero nunca te tenía/ te deseé pero no me deseaste*.

Y También la “mother” de Pink Floyd de la posguerra

“Madre, ¿me pondrás en la línea de fuego? Madre, ¿me estoy muriendo realmente?/Calla niño, no llores/Mamá va hacer que todas tus pesadillas se conviertan en realidad./Mamá te va inculcar todos sus miedo. Naturalmente, mamá ayudará a construir el muro”.

“Delante de ti me veo en el espejo que no acepta cambios, ni corbata nueva ni peinarse en esta forma. Lo que veo es eso que tú ves que soy, el pedazo desprendido de tu sueño”– dice Julio Cortázar de su madre en “La Madre”.

En este contrapunto sin tiempos dice César Vallejos:

“Ese pan generoso es oblación y es sagrado. Tú lo diste, madre, y es pan de amor.

La madre es harina. Pero también es el cuenco donde se amasa el pan dulce, el bizcocho. Es el recipiente y la vasija, si no el amor no tiene forma ni estructura. La madre es contenido y continente, harina y utensilio, donde se pueda amasar el pan de la vida ser el horno que lo cueza.”

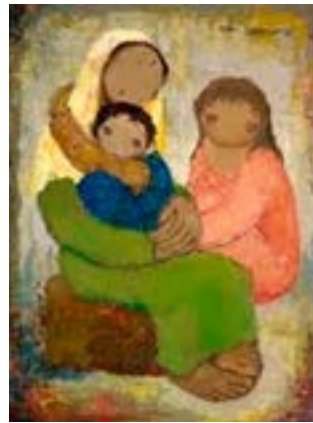
“Se la ve sencilla, honda y esencial, envuelta en un reboso raído, sin nada artificial que lo distinga, un arete, una cinta o un anillo. Se la siente arcilla, gleba, espiga; de rasgos muy andinos, telúricos y bondadosos, con ojos profundos, cabello lacio, pómulos salientes. Con mucha alma; servicial y entregada. Agua clara de manantial, mujer andina cabal”.

“Las manos de mi madre /llegan al patio desde temprano /todo se vuelve fiesta /

cuando ellas vuelan junto a otros pájaros/junto a los pájaros /que aman la vida /y

la construyen con los trabajos /arde la leña, harina y barro /lo cotidiano /se vuelve mágico”–, entonó desde el micrófono de su pc celestial Mercedes Sosa.

Federico García Lorca en “Mamá”.



“Mamá, yo quiero ser de plata/Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua./ Hijo, tendrás mucho frío/Mamá, bórdame en tu almohada./Eso sí!/¡Ahora mismo!”.

Miguel Hernández, desde la cárcel de esa Es-

pañá aún escondida y siempre muriente con una poesía para una madre, la de su hijo.

"Una mujer morena/resuelta en luna/se derrama hilo a hilo/sobre la cuna/ Ríete, niño,/que te tragas la luna/cuando es preciso".

Como suele pasar casi sin advertirlo, se nos cortó el zoom. No tenía un propósito claro. Pero, claro, aclaró que la salud es un concepto de integralidad, recreada por los artistas, entre otros.

***Dr. Juan Reichenbach**

CONCEPTO DOHAD. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE SALUD EN LA SALUD DE LAS FUTURAS GENERACIONES



DR. JORGE L. CABANA*

DRA. STELLA MARIS GIL**

Sumario

El concepto DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease), acrónimo inglés cuya traducción al español significa “Origen de la Salud y Enfermedad en el Desarrollo” describe cómo los estímulos ambientales -preconcepcionales y concepcionales- generan cambios en el metabolismo del feto a través de mecanismos epigenéticos, determinando su salud o enfermedad en la vida posnatal, con efectos que pueden manifestarse en el curso de la vida del individuo o en el de su descendencia.

Concepto DOHAD

Al decir de Heindel, DOHaD es una nueva área del conocimiento biomédico relacionada con la determinación de nuevas fuentes de causalidad entre eventos ocurridos en fases precoces del desarrollo y el surgimiento de enfermedades crónicas a lo largo del curso de la vida (Heindel. *Endocrinology*, 2016. (1): 17-22)

Ya a comienzos del Siglo XX algunos estudios epidemiológicos habían señalado relación causal en muertes de adultos y situaciones previas. Kermack en 1933 analizó las tasas de muerte histórica en Inglaterra, Escocia y Suecia señalando que “las cifras se comportan como si la expectativa de la vida fuera determinada por las condiciones existentes años anteriores”.

La “hambruna holandesa” en 1944, en el invierno de la segunda guerra mundial, se corre-

lacionó con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la edad adulta en la descendencia de las embarazadas de ese período.

En la década del 80, Barker y sus colaboradores analizando las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) en Inglaterra y Gales establecen una correlación entre dicha enfermedad y las condiciones perinatales vividas en esa población de condados pobres, y demuestra que existe una relación entre el bajo peso al nacer – particularmente el retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) y la ECV del adulto. Postula que el feto sometido a desnutrición disminuye su tasa de crecimiento para preservar el funcionamiento del cerebro en detrimento de otros órganos y se reducen funciones claves, produciendo alteraciones metabólicas y endocrinas y una mayor vulnerabilidad a factores ambientales adversos. (1)

Este enfoque de la teoría de Barker en lo nutricional se ha ido ampliando y aplicando en las bases de investigación en otras disciplinas, permitiendo avanzar en la comprensión del origen de la mayoría de las enfermedades no transmisibles (ENT).

DOHaD también es conocida como la ciencia de la programación o del desarrollo, dado que los estímulos ambientales en la vida intrauterina o aún antes de la concepción y en la etapa posnatal (particularmente hasta los dos años, etapa conocida como los “1000 días”) modifi-

can la programación del desarrollo, modelando la salud o la enfermedad en su vida adulta. De ahí la síntesis de Barker de “Una vida saludable comienza en el útero”.

EPIGENÉTICA

Los avances en biología molecular permitieron revelar algunos de los mecanismos por los cuales se modificaba la programación fetal, adaptando al organismo a las condiciones que el ambiente requería. A mediados del siglo pasado Conrad Waddington demuestra la trascendencia de la interacción gen-ambiente, acuñando el término Epigenética (del griego epi, en o sobre la genética). La epigenética es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes, sin modificaciones en la secuencia del ADN.

Hoy se sabe que a nivel molecular, ocurren mecanismos químicos en el ADN que sin cambiar su secuencia producen modificaciones en la expresión de los genes, permitiendo que algunos se expresen y otros no. Los mecanismos más conocidos son: 1) la metilación de la citosina de los pares citosina-guanina, 2) la modificación química de las histonas de la cromatina (por ej.: acetilación, metilación y fosforilación) y 3) la acción de los microARNs o ARNs de interferencia.

El ambiente a través de estos mecanismos regula la información genética presente en el ADN (genotipo), dando lugar a características específicas propias de cada individuo (fenotipo).

De acuerdo al estímulo ambiental, un mismo genotipo puede originar diversos fenotipos.

Así, el aforismo “*Los genes proponen y el ambiente dispone*” sintetiza cómo el ambiente condiciona la biología: los estímulos ambientales actúan sobre el genotipo (genoma) en un momento específico del desarrollo, generan modificaciones en la expresión de los genes (modificaciones epigenéticas) condicionando el desarrollo de distintos fenotipos (cambios en la funcionalidad y estructura de los órganos) en el momento de mayor plasticidad tisular.

Vulnerabilidad al ambiente en las etapas del desarrollo

El individuo es altamente vulnerable a los estímulos ambientales durante el desarrollo, especialmente en el período de mayor plasticidad de los tejidos.

Existen “ventanas críticas” o “períodos sen-

sibles” en el desarrollo, en los cuales una noxa puede determinar cambios en la organogénesis y funcionalidad.

La mayor o menor susceptibilidad a casi todas las enfermedades crónicas, está vinculada a estas “ventanas críticas”, donde la acción de factores ambientales diversos (nutrientes, estrés, sustancias químicas, drogas, manipulaciones hormonales, infecciones, etc.), determinan cambios epigenéticos. Hoy también se relacionan determinantes sociales como la pobreza y la violencia como factores que producen modificaciones en la arquitectura cerebral y comprometen el desarrollo cognitivo y la salud mental.

En el individuo en desarrollo existe una “programación normal” neurometabólica, hormonal, etc., mediada por sus genes. Un estímulo ambiental adverso puede activar los mecanismos epigenéticos para que el organismo se adapte y enfrente esas condiciones y altera la programación, modificando tanto la estructura como la fisiología de células y órganos, pudiendo afectar el crecimiento fetal y la salud en la vida adulta. Esta adaptación es mayor en la vida prenatal y posnatal temprana, durante el período de mayor plasticidad de los órganos y decrece a medida que el individuo avanza a su adultez. Es de destacar que las modificaciones epigenómicas son reversibles especialmente en las primeras etapas de la vida y que la adopción de hábitos saludables (dieta adecuada, actividad física, disminución del estrés, meditación, no consumo de sustancias, bienestar y realización socioeconómica) contribuyen a revertirlas y a que se expresen los “genes saludables” o “protectores” de enfermedades no transmisibles.

Los conceptos de “ventanas críticas”, “programación fetal” y “plasticidad” revelan que hablar de la etapa de los “1000 días” - desde la concepción y hasta los dos años de vida posnatal- es referirse a una etapa fundamental para la salud / enfermedad futura del individuo.

Si bien como dijimos anteriormente el concepto del origen de la enfermedad adulta en el desarrollo surgió con las observaciones epidemiológicas de carencias nutricionales, otros factores ambientales o estilos de vida adversos pueden conducir a enfermedades no transmisibles en la vida adulta a través de mecanismos epigenéticos u otros (inflamación crónica, estrés

oxidativo, alteraciones en la función placentaria, alteraciones hormonales materno-fetales) como vemos en el siguiente esquema:

A continuación describiremos en forma general cómo inciden los distintos factores ambientales en el desarrollo humano.

DOHAD y Nutrición

Los trabajos de Barker demostraron la significativa relación entre la malnutrición materna y el peso al nacer con el riesgo posterior de enfermarse, relacionándolo especialmente con ECV, hipertensión (HTA), DBT y obesidad en la descendencia. (1)

Investigaciones posteriores demostraron que también el alto peso al nacer se asocia a obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y esquizofrenia en la vida adulta.

También la malnutrición –déficit o exceso- particularmente en los primeros 1000 días de vida se relaciona con algunas enfermedades inmunológicas (asma, rinitis y dermatitis atópica), mentales (déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia) y reproductivas (trastornos de la fertilidad).

Diversos estudios demostraron que el feto y el niño en sus primeros años de vida debe recibir cantidades adecuadas de nutrientes para un neurodesarrollo normal, especialmente hierro, zinc, cobre, selenio y yodo, vitaminas como A, D, B 6 y B 12 y los cofactores colina y folato.

La carencia temprana de estos nutrientes en etapas sensibles se asocia con puntuaciones más bajas en el cociente intelectual, menor éxito escolar y trastornos del comportamiento, aun cuando fueran incorporados en etapas posteriores.

La deficiencia de hierro prenatal e infantil se asocia con trastornos en la conducta a largo plazo que pueden no ser reversibles, incluso con tratamiento posterior. El déficit de hierro en el adolescente también se asocia con deterioro neurocognitivo, aunque reversible con tratamiento. El yodo es indispensable para la síntesis de la hormona tiroidea. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (omega 3 y omega 6) Son esenciales para el crecimiento celular y el desarrollo neurocognitivo y deben incorporarse con los alimentos (atún, salmón, aceites vegetales y algunas nueces y semillas).

La leche humana, además de su valor nutricio-

Impacto de un ambiente adverso perinatal en la programación del desarrollo



Adaptado de Endocrinology, April 2016, 157(4):1328 –1340

nal ampliamente conocido promueve un desarrollo normal de la microbiota intestinal, aportando bacterias, hormonas y macronutrientes transmitidos por la leche materna.

Si bien excede a este capítulo la importancia del microbioma intestinal en la salud del individuo, señalamos que:

El normal desarrollo de la microbiota contribuye no sólo a mejorar la salud de los niños en los primeros años de vida – protección contra enfermedades diarreicas, respiratorias y alérgicas –, sino que tiene impacto demostrado en la prevención de ENT y en general en la salud en la vida adulta.

En la maduración del microbioma intestinal resulta decisiva la lactancia y una dieta adecuada hasta que el niño llegue a los 2 o 3 años de edad. Luego su composición se estabiliza y se establece la base del microbioma similar al del adulto.

La menor duración de la lactancia materna, el estrés y el uso de antibióticos antes del destete, está asociada con alteraciones de la microbiota intestinal.

DOHAD, Estrés y Experiencias Infantiles adversas (EIA)

La respuesta al estrés tanto en animales como en seres humanos incluye un aumento de hormonas específicas. Cuando el estrés se produce en etapas sensibles del desarrollo donde la plasticidad es mayor, particularmente los primeros 1000 días de vida y hasta los cinco años del niño, ese aumento hormonal puede alterar la arquitectura normal del cerebro.

La exposición pre y postnatal a eventos adversos que generan estrés ejerce consecuencias a corto y largo plazo, produciendo efectos duraderos en la estructura y el comportamiento neuronal. Esto implica un rol en la etiología y la evolución de varias enfermedades incluyendo síndromes metabólicos, trastornos psiquiátricos y deterioro de la cognición.

Se clasifican como experiencias infantiles adversas a: (2)

- Abuso emocional
- Abuso físico
- Abuso sexual
- Negligencia emocional
- Negligencia física
- Maltrato violento a la madre
- Abuso de sustancias en el hogar

- Enfermedades mentales en el hogar
- Separación o divorcio de los padres
- Encarcelamiento de un miembro del hogar

Una respuesta prolongada y patológica al estrés provocado por alguna de estas experiencias produciría modificaciones epigenéticas en la transcripción del ADN que llevarían a cambios estructurales del cerebro en desarrollo, con consecuencias significativas en el aprendizaje, la conducta, y el desempeño social de la persona.

En estudios de resonancia magnética, se han comprobado alteraciones a nivel anatómico, tales como reducción del tamaño del hipocampo, menor materia gris en la corteza prefrontal y en la amígdala.

Otros estudios relacionan el desarrollo cerebral con la pobreza, demostrando diferencias en el desarrollo del lóbulo frontal (funciones ejecutivas) y el lóbulo temporal (vinculado al lenguaje) que podrían explicar hasta el 20 % de los déficits de aprendizaje de los niños y niñas de menores ingresos (Hair et al. 2015).

En el estrés crónico se descontrola la respuesta adaptativa, por lo cual el individuo reacciona con repuestas inadaptadas y destructivas aún frente a estímulos poco estresantes. Estudios experimentales muestran que ratones separados de sus madres en los primeros días de vida (abandono) se mostraron menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés a lo largo de su vida y su memoria fue más pobre que los que no fueron separados.

Los mecanismos involucrados comprenden alteraciones epigenéticas en el eje Hipotálamo-Hipofisis-Adrenal, alterando la plasticidad y el desarrollo del sistema nervioso.

En niños menores institucionalizados con desórdenes depresivos, abuso e intentos de suicidio se han hallado modificaciones epigenéticas en genes asociados al desarrollo y las funciones cerebrales.

Podemos decir que ciertas experiencias infantiles adversas se asocian con un incremento de riesgos sociales, problemas de salud mental, abuso de sustancias, violencia doméstica y adopción de estilos de vida riesgosos en la vida adulta. Estas consecuencias pueden afectar negativamente a la parentalidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos.

DOHAD y exposiciones a químicos ambientales

Hasta no hace mucho tiempo, se creía que la placenta constituía una verdadera barrera que filtraba ciertas moléculas químicas, pero hoy está demostrado que cientos de contaminantes ambientales pueden medirse en sangre de cordón umbilical.

La exposición a ciertos químicos puede alterar el patrón epigenético en órganos en desarrollo, principalmente sistema nervioso, endocrino y respiratorio. Estos cambios epigenéticos persisten en la vida y pueden ocasionar una mayor susceptibilidad para determinadas patologías.

Es materia de numerosas investigaciones la relación entre el aumento significativo de enfermedades del neurodesarrollo, obesidad, cáncer, asma, trastornos en la reproducción, endócrinos e inmunológicos y su relación con exposiciones a químicos ambientales durante el desarrollo.

Si bien estudios en animales han demostrado relación causal, los estudios en humanos conllevan varias dificultades especialmente por las exposiciones múltiples que dificultan establecer una relación causa-efecto precisa y el largo tiempo transcurrido entre las exposiciones a químicos ambientales y la aparición de las enfermedades (período de latencia).

Los efectos de la exposición al humo de tabaco, al plomo, al metilmercurio, al dietilestilbestrol y al alcohol han sido ampliamente estudiados y existe una vasta descripción al respecto en la literatura científica.

El Síndrome alcohólico fetal constituye una entidad nosológica conocida, caracterizada por alteraciones faciales, hiperactividad, déficit cognitivo y de atención, desajustes de memoria, discordinación motora y mal funcionamiento psicosocial. Hoy se sabe que no existe umbral seguro para el consumo de alcohol durante el embarazo y que aún la exposición prenatal al alcohol también a bajas dosis puede aumentar el riesgo de enfermedad mental en la descendencia. (4)

La exposición a plaguicidas y compuestos sintéticos, a metales pesados como plomo, arsénico, níquel y cadmio en el embarazo puede producir modificaciones epigenéticas por algunos de los mecanismos conocidos.

Algunos de estos compuestos actúan como disruptores endócrinos (DE), o sea, sustancias

que causan alteraciones en la función endócrina y en consecuencia efectos adversos en la salud de un organismo sano o en su descendencia- (OMS)

Los DE son moléculas muy pequeñas, con vida media muy prolongada, lipofílicas que se bioacumulan en tejido adiposo y se transmiten en la cadena alimentaria.

Pueden producir alteraciones en cualquiera de los principales sistemas endocrinos, incluyendo el reproductivo, tiroideo y adrenal. Están relacionados con enfermedades ováricas, disfunción testicular; pubertad precoz, trastornos reproductivos, endometriosis, abortos, cambios en el comportamiento social; aumento del depósito adiposo y el tamaño de los adipocitos, hígado graso, etc.

Las características descritas para los DE y su distribución universal en plaguicidas, domo-sanitarios, cosméticos, plásticos, fármacos, residuos industriales y alimentos son elementos que potencian su riesgo. Por otro lado, no existe para los DE una dosis-respuesta tradicional, ni niveles seguros de exposición o una "dosis" que pueda considerarse segura y medirse.

La carga de contaminación ambiental que recibe el bebé de su madre a través de la placenta y el avance de las ciencias ambientales, nos muestran la necesidad de tomar conciencia de proteger el ambiente y que en particular la embarazada y los niños accedan a ambientes saludables.

Herencia intergeneracional

Uno de los hallazgos más significativos relacionados con el paradigma DOHAD en modelos animales es que el riesgo de enfermedad puede transmitirse de generación en generación.

Una exposición o experiencia durante el embarazo tiene la capacidad de afectar a tres generaciones de una sola vez: la madre, el niño en gestación, y los gametos en desarrollo del embrión/feto en desarrollo.

El óvulo que en el futuro será fertilizado –nieto– ya está formado cuando su madre es un embrión de 6 a 8 semanas durante el embarazo de la abuela.

Así las exposiciones ambientales de la abuela (nutrición, químicos, EIA, estrés) pueden influir en las modificaciones epigenéticas en el óvulo y subsecuentemente en el futuro individuo, afectando



tando de esta manera a tres generaciones.

Algunas enfermedades o cambios en la expresión génica se pueden encontrar incluso en la cuarta generación (bisnietos).

Los estudios epidemiológicos que originaron la Hipótesis de Barker demostraron que la desnutrición intrauterina puede inducir cambios epigenéticos en la línea germinal, que están relacionados con alteraciones y un mayor riesgo de síndrome metabólico en generaciones siguientes.

Otros estudios demostraron que cuando la madre gestante estuvo expuesta a dietas bajas en proteínas, restricción calórica, dietas altas en grasas, la descendencia padecía efectos sobre la tolerancia a la glucosa, la presión arterial, el peso corporal, la resistencia a la insulina, la inmunidad, la reproducción y disfunciones neurológicas.

Estas evidencias nos muestran que recibimos una herencia parental y somos el resultado modelado por las experiencias y estímulos ambientales positivos o negativos de nuestros padres y abuelos, al cual sumamos las experiencias propias en el curso de la vida.

La vía paterna ha sido menos estudiada, y es necesaria más investigación sobre el papel del padre en la transmisión de mensajes epigenéticos. Un estudio de cohorte publicado en Suecia, estableció correlación significativa entre la disponibilidad de alimentos de los abuelos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes en sus nietos (5).

Factores paternos como la edad, estilo de vida, altura, IMC y tabaquismo han sido estudiados en relación con el aumento de los riesgos en la descendencia, sin encontrar evidencia concluyente. (6)

Curso de Vida (CV)

Es un concepto dinámico que analiza cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran las vidas individuales y las generaciones.

Curso de vida provee un marco conceptual que permite entender como múltiples determinantes de la salud interactúan a lo largo de la vida y entre generaciones para producir resultados en salud (NEILS 2010).

La salud individual y comunitaria es el resultado de un proceso, una interacción dinámica entre factores que favorecen la salud (factores de protección) y factores que aumentan el riesgo de enfermar (factores de riesgo).

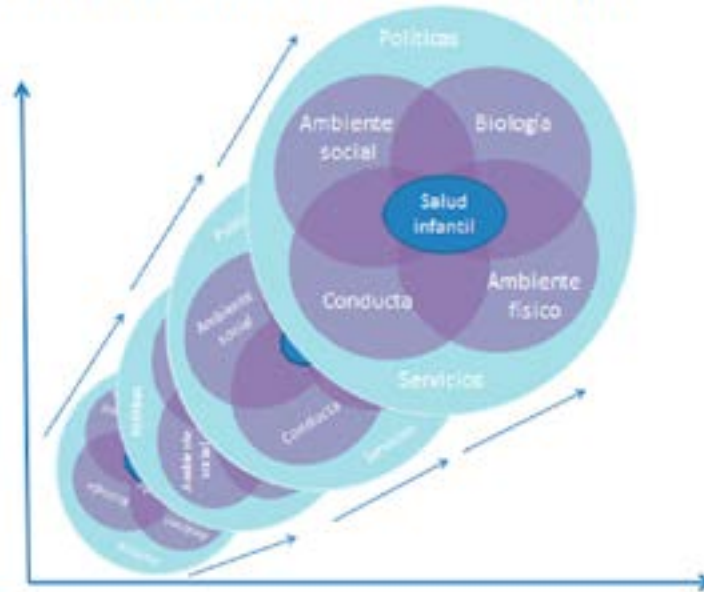
Con los conocimientos actuales que aporta la epigenética y la epidemiología, las interacciones que determinan la salud / enfermedad en el curso de la vida comienzan antes de la concepción del individuo, involucra el presente y trasciende a futuras generaciones.

En este modelo que semeja un caleidoscopio, la Salud Infantil como centro es el resultado de dos ejes: el horizontal que grafica la influencia de las variables que la condicionan en un momento determinado: ambiente físico y social, la biología y las conductas del individuo, en el marco de los servicios que recibe como resultado de las políticas públicas.

El eje vertical grafica la suma de aportes que brindan esos mismos elementos a lo largo del tiempo, dando como resultado la situación actual. Cada vuelta del caleidoscopio grafica la situación actual que incluye las anteriores y aportará para las futuras.

“El enfoque de Curso de Vida es una aproxima-

Modelo de salud en el curso de la vida: Caleidoscopio



Fuente: *Children's Health: A New Conceptual Framework.* National Research Council and Institute of Medicine. 2004

ción a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, configura un salto de un enfoque evolutivo a un enfoque interrelacional, vinculando una etapa con la otra y definiendo factores protectores y de riesgo en el acontecer futuro, en el marco de los determinantes sociales” (Document ed politique économique et sociale DPES 2011-2015)

Los resultados inmediatos en salud (atención de la enfermedad actual), adquieren su real dimensión en el contexto más amplio del curso de vida de ese individuo y de su grupo (cohorte) o generación.

También amplia el enfoque del concepto de Prevención, poniendo énfasis en el cambio de hábitos y costumbres, así como en políticas públicas que los sustenten.

Concepto DOHaD y Curso de Vida redefinen el rol del equipo de salud.

Transición epidemiológica -

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la principal causa de mortalidad en el mundo.

La OMS señala en su documento “Lucha contra las ENT “del año 2017 que 8 de cada 10 personas mueren en el mundo a consecuencia de alguna ENT, siendo las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y neumopatías crónicas las principales involucradas. (OMS “Lucha contra las ENT”2017)

Los datos para América Latina y Argentina son similares.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que “Las enfermedades no transmisibles son la causa principal de enfermedad y muerte prematura y evitable en la Región de las Américas.” (7)

El mismo informe señala que las muertes anuales por ENT en la Región superan los 5 millones, el 34% de las cuales son prematuras (personas de 30 a 69 años), afectando especialmente al 20% de población más pobre.

En Argentina el último reporte de monitoreo de evolución de las ENT en las Américas de 2017, señala que el 81% de las muertes se producen por ENT, el 17% de las cuáles ocurren prematuramente.

La Argentina, al igual que gran parte del mundo, transita por una transición epidemiológica donde las Enfermedades no Transmisibles (ENT) han desplazado a las Enfermedades Transmisibles (ET) como causa de morbilidad y mortalidad.

Esta situación reconoce distintas causales, entre ellas el éxito en el control de las enfermedades transmisibles (vacunación, medidas de higiene, etc.), y variables demográficas como el envejecimiento poblacional, la urbanización y la exposición a factores de riesgo para ENT. (8)

El envejecimiento poblacional, aparece impulsado por dos factores sinérgicos: el aumento de

la esperanza de vida de la población y la disminución de la tasa de natalidad. Ambos factores tienen una tendencia similar en la Argentina.

Estos procesos impactan en todos los ámbitos, particularmente en salud.

Para OMS *“...el alcance de las oportunidades de una mayor longevidad dependerá, en gran medida, de un factor clave: la salud. Si las personas viven esos años adicionales en buen estado de salud, su capacidad para hacer lo que valoran será apenas diferente a la de una persona más joven. Pero si esos años adicionales se caracterizan por disminución de la capacidad física y mental, las consecuencias para las personas mayores y para la sociedad serán mucho más negativas.”* OMS- Informe Mundial sobre envejecimiento y salud -2015

En este nuevo contexto de transición epidemiológica, sin descuidar las acciones para el control de las enfermedades transmisibles:

La prevención de ENT se vuelve prioritaria

Cambia el concepto de prevención, priorizando la calidad de vida de cada persona y de su comunidad.

El Concepto DOHAD aporta evidencias y una visión que redimensiona el accionar del equipo de salud, particularmente el materno infantojuvenil.

¿Por qué incorporar el concepto DOHAD en la formación pediátrica?

Porque el pediatra está en una situación de privilegio para asesorar en prevención desde el comienzo de la vida.

La Prevención aparece como una actividad propia de todo buen enfoque en salud.

Se reconocen la Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria a las que se han agregado más recientemente los conceptos de Prevención Primordial y Prevención Cuaternaria.

Prevención secundaria, terciaria y cuaternaria orientan su accionar al individuo ya enfermo, procurando evitar las complicaciones y limitar los alcances de su enfermedad, rehabilitar las funciones comprometidas y protegerlo de la iatrogenia.

Prevención Primaria y Prevención Primordial definen su accionar tanto sobre el individuo como sobre la comunidad y son herramientas de la salud pública, en forma sinérgica y comple-

mentaria.

Desde la perspectiva de Concepto DOHAD y Curso de Vida, la prevención orienta hacia actividades de Prevención Primaria y/o Prevención Primordial.

1-PREVENCIÓN PRIMARIA: Es toda intervención destinada a evitar o prevenir la aparición de determinado trastorno o enfermedad en un individuo o en una comunidad.

Presupone el conocimiento de una enfermedad, sus causales y/o los elementos de riesgo para padecerla, lo que permite elaborar estrategias e intervenciones en el individuo o la comunidad que disminuyan los riesgos de contagio, o la exposición a los factores de riesgo, evitando que los expuestos se enfermen.

Actúa básicamente sobre la población de riesgo.

Los programas de vacunación de los países, las medidas higiénicas para el aislamiento de un caso o para el control de vectores, los avances en la prevención de las complicaciones de las ENT, constituyen algunos de los elementos de la prevención primaria.

“La Prevención primaria se dirige a limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y factores de riesgo; implica medidas de protección de la salud, en general a través de esfuerzos personales y comunitarios” (OPS. Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades, segunda edición-2011)

2- PREVENCIÓN PRIMORDIAL: Comprende a la intervención a individuos o comunidades, no portadores de factores de riesgo, para evitar los adquieran.

Presupone el estudio y conocimiento de los factores protectores o de riesgo que pueden influir en la salud o enfermedad de un individuo o comunidad (ej: fumar es nocivo para la salud)

Actúa sobre toda la población con una visión anticipatoria, buscando generar intervenciones dirigidas a:

- ✓ disminuir la prevalencia de los hábitos nocivos
- ✓ evitar la aparición de los factores de riesgo
- ✓ incrementar los hábitos y conductas saludables
- ✓ estimular los factores protectores de la salud actual o futura.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de individuos y comunidades, generando nuevos

patrones sociales, económicos y culturales o modificando los existentes.

“La Prevención primordial se dirige a evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida sociales, económicos y culturales que contribuyen a elevar el riesgo de enfermar; éste es el nivel de prevención más recientemente reconocido y tiene gran relevancia en el campo de la salud poblacional.” (OPS. Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades, segunda edición-2011)

Los resultados no son visibles en forma inmediata y su eficacia se mide en el tiempo, a veces en generaciones.

DOHAD y Accionar del equipo de salud

Es necesario ampliar la mirada del accionar médico – particularmente del equipo de salud materno infantojuvenil- hacia los antecedentes y el ambiente. Esto ayudará a entender los fundamentos profundos de la situación actual y decidir conductas con una visión amplia sobre la mejor solución que contemple su futuro y el de sus descendientes.

El concepto DOHAD y de Curso de Vida modifican el concepto de salud/enfermedad, planteando nuevos paradigmas y nuevas perspectivas de viejos temas, especialmente en salud materno infanto juvenil.

Muchas de las acciones propuestas como buenas prácticas médicas no son nuevas e incluso han sido los pilares de la atención pediátrica desde el reconocimiento de la especialidad (atención del recién nacido, promoción de la lactancia, nutrición adecuada, cuidado del desarrollo, etc.) pero adquieren una nueva perspectiva desde el concepto DOHAD, con una nueva responsabilidad en la salud de las futuras generaciones.

Principios generales:

1.- Intervenciones tempranas tienen mayor impacto.

Considerando los conceptos de programación y plasticidad, la edad de exposición es determinante en las manifestaciones posteriores.

En el curso de la vida las intervenciones tempranas donde la plasticidad epigenética es mayor, pueden modificar en el largo plazo la evolución hacia una mayor salud o enfermedad de

los individuos en la vida adulta. A medida que el individuo envejece, la efectividad de las acciones preventivas es menor.

Las acciones de prevención que apunten a la etapa preconcepcional y a los primeros 1000 días de vida resultarán de mayor impacto.

2.- Período de latencia

Desde el Concepto DOHAD las manifestaciones de salud o enfermedad en el curso de la vida de un individuo derivadas de una acción médica preventiva, no son inmediatas y muchas veces – por el tiempo necesario para que tengan efecto- tampoco “visibles” para quién genera la acción.

Existe un período de latencia no medible que puede abarcar muchos años, incluso manifestarse en generaciones futuras.

Este concepto enfatiza la importancia de los estudios de cohorte que permiten el seguimiento de una misma población a lo largo de generaciones.

También refuerza la perspectiva de una nueva dimensión temporal del accionar médico re-dimensionando el rol del equipo de salud, con resultados que probablemente se verán en las futuras generaciones.

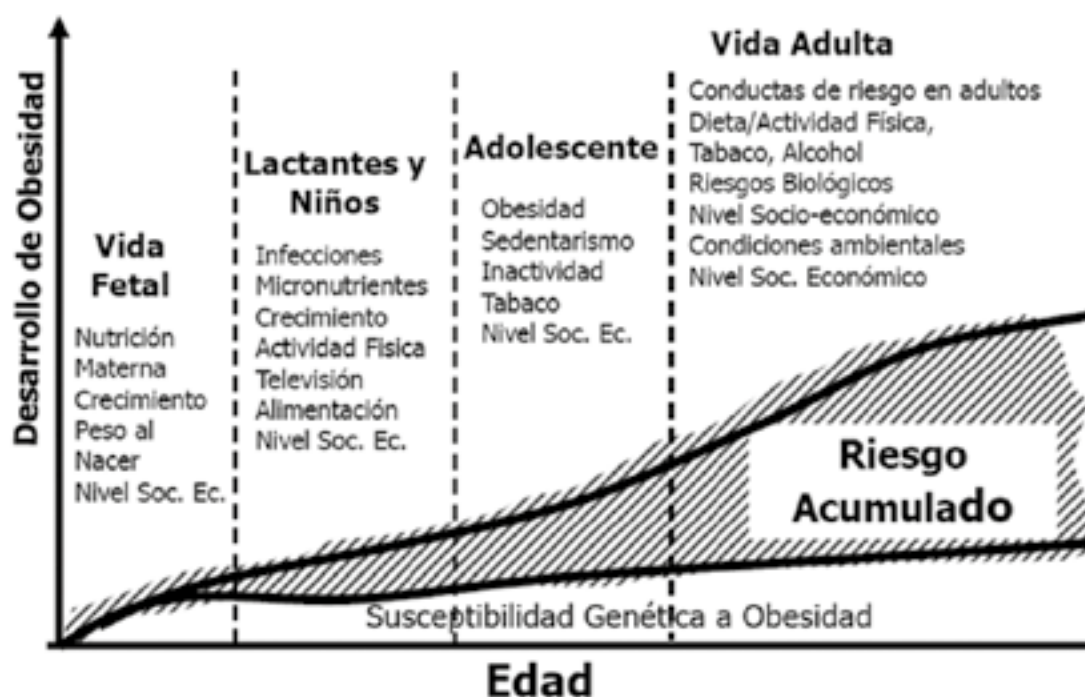
3.- Riesgo acumulado – Oportunidades perdidas de accionar

Los condicionantes de salud / enfermedad presentes desde la concepción pueden mantenerse latentes o se les pueden sumar en el curso de la vida del individuo nuevos elementos de protección / riesgo, aumentando o disminuyendo la carga de salud / enfermedad del individuo.

Es lo que se denomina riesgo acumulado para una misma enfermedad y justifica el accionar preventivo tan temprano como sea posible, dado que lo que no se haga en un momento de la vida del individuo se acumula como riesgo mayor para su futuro.

Es responsabilidad del accionar pediátrico y del equipo de salud materno infanto juvenil, evitar que esas sean oportunidades perdidas.

A modo de ejemplo en el siguiente gráfico se muestra el riesgo acumulado de Obesidad en el Curso de la vida, lo que puede ser extrapolado a cualquier ENT (ECV, Asma, Cáncer, HTA, etc.)



Adaptado de OMS- Geneve- 2002

Prevención de Obesidad en el Curso de la Vida *Adaptado de OMS- Geneve- 2002*

Las nociones de “período de latencia” y de “riesgo acumulado” facilitan que la mayoría de las ENT no sean “visibles” en forma inmediata, lo que dificulta la percepción de riesgo por parte de la población e incluso por el equipo de salud que trabaja con niños y adolescentes.

Accionar pediátrico

Los pilares para una buena medicina preventiva son la práctica clínica y un esfuerzo intersectorial e interdisciplinario con políticas públicas adecuadas.

La práctica clínica será nuestra principal ayuda diagnóstica, dado que el laboratorio puede aportar pruebas limitadas (dosaje de algunos tóxicos o micronutrientes) y la detección genética o epigenética no es accesible por el momento.

La Historia Clínica es la herramienta fundamental en la detección de factores de riesgo para ENT.

La adecuada anamnesis debería orientarnos a conocer la historia personal, familiar, ambiental y social, brindando elementos para

Buscar las raíces cuando estemos frente a niños con obesidad, asma, atopía, retraso en el desarrollo, trastorno por déficit de atención / hiperactividad, DBT, problemas de salud mental y

del comportamiento, etc.

Detectar factores de riesgo para las ENT cualquiera sea la edad de consulta – particularmente en los primeros 1000 días de vida-, que nos permitan una consejería adecuada.

Del accionar en la consulta podrá depender generar acciones en los momentos de mayor plasticidad y evitar una mayor acumulación de riesgo al existente.

Los beneficios de dichos cuidados no serán visibles inmediatamente, pero para el niño serán de por vida e incluyen una mejor salud y una realización plena del individuo, de su entorno, con efecto en su descendencia.

Creemos en la necesidad de “incorporar en el primer nivel de atención el concepto del origen temprano de la salud y la enfermedad” porque “esto redefine y jerarquiza nuestro rol como integrantes del equipo de salud materno infanto juvenil”. (9).

Las acciones prioritarias de los pediatras para evitar las ENT son:

- ✓ Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y continuada hasta los dos años, así como la introducción de una alimentación complementaria oportuna y saludable
- ✓ Establecer estrategias para una adecuada atención de adolescentes, fomentando en

mujeres y varones hábitos y conductas saludables. El cuidado integral del adolescente mejorará el ambiente concepcional de las futuras generaciones.

- ✓ Realizar el seguimiento del desarrollo de nuestros niños y la detección temprana de sus alteraciones.
- ✓ Promover una atención prenatal y perinatal adecuada, con regionalización de los recursos.
- ✓ Promover ambientes saludables: evitar las exposiciones tóxicas y garantizar una buena calidad de aire, agua y alimentos especialmente en la embarazada y el niño.

Además del esfuerzo individual, para el logro de estos objetivos son necesarios acuerdos y

tareas intersectoriales e interdisciplinarias, en el marco de políticas públicas orientadas a la prevención de ENT, con objetivos y metas evaluables para el mediano y largo plazo.

Para la OMS *“la prevención y el control de las Enfermedades no transmisibles (ENT) requiere intervenciones dirigidas a las 4 principales enfermedades (ECV, Obesidad, DBT e HTA) y sus factores de riesgo”*, priorizando las acciones de políticas públicas orientadas a Reducir el uso nocivo de alcohol, Reducir el consumo de tabaco, Promover la Actividad física y Promover una dieta saludable.

El documento “Compromiso Conjunto para la Prevención de Enfermedades no Transmisibles” firmado por la SAP con OPS/OMS, UNICEF, Ministerio de Salud de la Nación y varias entidades

MUCHAS ENFERMEDADES DEL ADULTO TIENEN SU ORIGEN EN LA VIDA FETAL O EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y PUEDEN TRANSMITIRSE A FUTURAS GENERACIONES:



- Alteraciones en la reproducción
- Obesidad
- Diabetes
- Cáncer
- Enfermedad cardiovascular
- Alteraciones en el neurodesarrollo
- Enfermedad pulmonar crónica

¿COMO PREVENIRLAS?

- Atención prenatal y perinatal adecuadas, con regionalización de los recursos.
- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y continuada hasta los dos años.
- Introducción de una alimentación complementaria oportuna y saludable.
- Seguimiento adecuado del desarrollo de nuestros niños y detección temprana de sus alteraciones.
- Promoción de ambientes saludables.
- Establecer estrategias para una adecuada atención de adolescentes.



Aconseje a su paciente cómo forjar una vida saludable para sí y las futuras generaciones



científicas (9) los firmantes se comprometen a trabajar en la prevención de ENT estableciendo 12 objetivos y finalizan señalando que “Se acuerda que la mejor manera de avanzar en la prosecución de estos objetivos es actuar en forma interdisciplinaria e intersectorial, en lo cual (los firmantes) comprometen sus esfuerzos”.

Los acuerdos intersectoriales e interdisciplinarios para la prevención de ENT adquieren verdadera fortaleza y trascendencia cuando se logran en el nivel local, donde cada realidad tendrá respuestas acordes, que podrán ser monitoreadas.

Conclusión

El Concepto DOHAD marca “un antes y un después” en los enfoques de la salud del individuo y de las comunidades. Las principales causas de muerte en la población es por ENT, que tienen su origen en etapas tempranas de la vida. Por lo tanto el pediatra tiene un rol indiscutible en la promoción de hábitos saludables, en fomentar la lactancia y promover una dieta adecuada y en evitar exposiciones tóxicas para prevenir las ENT. El campo de la investigación en Concepto DOHAD ofrece aún mucho por hacer, tanto en investigación clínica como en estudios poblacionales de cohortes que aporten datos locales y regionales.

Descubrir que el ambiente puede modificar la expresión de los genes en períodos sensibles de la vida y condicionar la salud o enfermedad para toda la vida, nos presenta una nueva perspectiva en la comprensión de las enfermedades y nos sitúa en una posición privilegiada para fortalecer la prevención desde antes de la concepción.

Las ENT constituyen una epidemia y un desafío a la salud pública y nuestra visión de la prevención debe ampliarse, considerando conductas anticipatorias de prevención (prevención primordial) y no sólo lo urgente.

Lograr una adolescencia sana, un embarazo y un parto saludable, una crianza afectuosa, lactancia materna seguida de una nutrición adecuada, protección de los tóxicos ambientales y prevenir las experiencias infantiles adversas, estimular el juego y la actividad física, brindar oportunidades para el aprendizaje adecuado, son las bases para un desarrollo saludable y la mejor prevención para ENT.

Los beneficios de dichos cuidados no serán visibles inmediatamente, pero duran toda la vida

e incluyen una mejor salud y una realización plena del individuo, de su entorno, con efecto en su descendencia.

Nuestra responsabilidad como pediatras, integrantes del equipo de salud materno infanto juvenil, no es sólo con la salud de nuestros pacientes, sino también con la de las futuras generaciones.

RECORDAR QUE: Del equipo de salud materno infanto juvenil depende un buen o un mal comienzo en la vida y la salud de las futuras generaciones...

Referencias

1. *Mothers, Babies and Disease in Later Life – David Baker Parents’ Adverse Childhood Experiences and Their Children’s Behavioral Health Problems.* Adam Schickedanz, Neal Halfon, Narayan Sastry, Paul J. Chung
2. *Pediatrics* Aug 2018, 142 (2) e20180023;
3. <http://www.neuroepigenetica.qb.fcen.uba.ar/wp-content/uploads/2017/12/How-poverty-affects-the-brain.pdf>
4. *Prenatal alcohol exposure and developmental programming of mental illness.* Burgess DJ and Moritz KM. *Journal of Developmental Origins of Health and Disease* doi: 10.1017/S2040174420000082
5. Kaati G, Byggen LO, Edvinson S. Cardiovascular and diabetes mortality determined by nutrition during parents and grandparents’ slow growth period. *Eur J Hum Genet* 2002; 10(11):682-8
6. *The effect of paternal factors on perinatal and paediatric outcomes: a systematic review and meta-analysis.* Nan B. Oldereid, Ulla-Britt Wennerholm, Anja Pinborg, Anne Loft, Hannele Laivuori, Max Petzold, Liv Bente Romundstad, Viveca Söderström-Anttila, and Christina Bergh <https://academic.oup.com/humupd/advance-article-abstract/doi/10.1093/humupd/dmy005/4859613>
7. OPS-Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019” <https://iris.paho.org/handle/10665.2/35010>
8. STRATEGY FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF NON-COMMUNICABLE DISEASES <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-9-s.pdf>
9. https://www.sap.org.ar/uploads/boletines/boletines_ano-xliii-n-1-abril-2016-17.pdf

*Dr. Jorge L. Cabana

Médico Pediatra.

Especialista Consultor en Neonatología

Especialista Consultor en Clínica Pediátrica.

Ex Presidente Sociedad Argentina de Pediatría

**Dra. Stella Maris Gil

Médica Pediatra.

Coordinadora Unidad Pediátrica Ambiental. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Docente Adscripto de Pediatría. UBA

Ex Presidenta Sociedad Argentina de Pediatría

ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE



DRA. EVA JOSEFINA QUINTEROS FLEITES*

Los niños que acuden a los centros de salud y a los hospitales, casi siempre están enfermos; el objetivo es reflexionar lo que significa atención integral. Implica un cambio de paradigma. No solo curar, sino prevenir, cuidar, rehabilitar, si fuera necesario. También significa “Sonreír” y apoyar, no solo a los infantes sino a los que les acompañan en el día a día.

Los estudiantes deben crecerse en la asimilación y adquisición de la mirada integral, y no solo la mirada, sino del actuar; preocuparse por la salud de los niños y las niñas y no solo hacia los niños enfermos. Las enfermedades deben ser estudiadas detalladamente ya que poseen diversas formas de presentación y siempre se debe ser exhaustivo y analizar en detalle no solo al niño, sino todo el entorno, familia o comunidad. Todo debiera ser indagado pues quizás no se indagó lo suficiente y no debían existir cosas de las cuales no se posea el dominio integral; ahora lo que se pretende es hacer llegar a todo lo relevante del cuidado del niño, de una cultura de salud que empiece desde el primer día de vida, y sea una constante en cada una de las consultas, aunque esta se realice por una lesión en la piel o por diarreas. Es muy importante empezar con un principio enunciado por José Martí en 1883 que expresa: *La verdadera medicina, (aquí yo siempre digo la verdadera pediatría) no es la que cura sino la que precave* (1). Más vale indicar al que se acerca a un despeñadero como apartarse de él, que tener que recomponer los huesos del que cae rebotando por él. Ojalá en cada contacto con un niño, niña o adolescente seamos capaces de enseñarles algo sobre la po-

sibilidad del Autocuidado (2). Hay miles de cosas y en cada oportunidad se puede estimular o direccionar hacia temas diferentes ¿Se han preguntado cuántos niños de los que pasan por las consultas saben el cuidado de sus dientes? Puede que no todos tengan un cepillo de dientes y de tenerlo no conozcan que es necesario cepillarse cuatro veces al día. Quizás muchos ya están pensando en que esa es responsabilidad del odontólogo o de la enfermera: todos debiéramos actuar sin pensar que otros profesionales pueden hacer esa acción.

Además de enseñarles a auto cuidarse se debe enseñar la práctica de la ayuda mutua (2). Nadie enseña mejor a un niño que otro niño o a un adolescente otro adolescente. Todos sabemos que eso se llama Ayuda de pares y es efectiva y se pudiera enseñar a cómo hacerlo en relación a cosas de utilidad como la dieta saludable, la prevención de la obesidad, las horas de ejercicios físicos que deben practicar al día (3). Son inmensos los ejemplos que pueden ser puestos en práctica por niños y adolescentes y así no llegarían a enfermar. Eso es integralidad, es pensar no solo en curar la lesión que nos muestra en su piel o en su cara, es enseñarles a desarrollar una cultura de salud.

El último de los aspectos sería el cuidado del entorno; entorno familiar. No a los gritos, no a la violencia o en estilo positivo: hablar en tono bajo, pedir por favor, o sería posible que... me ayudarían a...esto o aquello....

El entorno también se refiere a las amistades que cultivan los adolescentes. Todos conocemos que si el amigo fuma, él le imitará y si ingie-

re bebidas alcohólicas será invitado a compartir y puede que no se pueda detener nunca más. En el caso de los adolescentes, se conoce que el grupo de amigos será escuchado por el adolescente por ello se debe intentar que el grupo sea positivo con tendencias hacia el cuidado de la salud.

Estas tres advertencias, autocuidado, ayuda mutua y ambiente sano, son muy necesarios para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. No solo curarles es la tarea de los pediatras, hay que cuidarles y enseñarles a cuidarse y enseñar a las familias a que contribuyan a cuidar de la salud de ellos sobre todo con armonía, amor, amistad. Fíjense que todo empieza con A como Julio Monsalvo (4) un médico Argentino amigo que habla de la Alegremia, alegría en sangre, es un término suyo y él habla de otras muchas cosas buenas que empiezan con A y que él invita a pensar, como el aire, el agua; es responsabilidad de todos que el aire no esté contaminado, con el humo del cigarrillo ni con los miles de contaminantes del entorno. Así el agua es un elemento fundamental para la vida, pero tiene que estar sin gérmenes, que pueden producir enfermedades que ustedes puede que conozcan, producen enfermedades graves y hasta pueden producir la muerte por deshidratación o por infecciones graves.

Integralidad es llamarle por el nombre y tratarlo como si fuera un buen amigo o un hijo o un vecinito querido. Justo es que se le considere en estrecho vínculo con su mamá y con una familia, que se le valoren los aspectos psicológicos que puedan estar afectándolo o haciéndole sentir feliz. Ese otro que vive en un barrio pobre y apenas tiene esa ropa que hoy le puso su mamá o su abuela, para asistir al centro de salud, quizás para él, es otro el problema principal, quizás no tuvo juguetes o no ha desayunado o se acostó sin comer anoche. Las realidades son en ocasiones bien diferentes y solo ofrece atención integral el que además de examinar la lesión de la piel, que fue el ejemplo ofrecido, tiene en consideración muchas aristas que si no se expresan deben ser indagadas por los profesionales de la salud, con ética y con respeto y sin violar los derechos humanos.

El contacto físico como pudiera ser darle una palmadita en el hombro o acompañar nuestras orientaciones con una sonrisa y una mirada de apoyo total. Eso es muy necesario.

También puede que ese niño o niña no posea una buena audición o una buena visión y ello explique el por qué sus rendimientos escolares distan de ser los mejores. Alguien debe tomarse un tiempo para hacer el diagnóstico adecuado en el momento adecuado.

Los seres humanos no son solo pulmones, corazones o riñones, en un cuerpo, y como tal debe ser examinado integralmente; otras esferas deben ser examinadas y rescatadas, así podremos rehabilitar alguno de esos aspectos. La visión deficiente o la audición deficiente pueden recuperarse a tiempo y ello puede repercutir en la sociedad.

Hace quizás más de 50 años atrás, el pediatra, era aquel profesional que atendía a los niños y niñas en las salas de los Hospitales pediátricos, que evolucionaban según los momentos del año y estación; en los meses de lluvias y mucho calor, en las salas destinadas a las EDA abundaban los ingresos por enfermedades diarreicas agudas y eran muchos los niños, que ingresaban y muchos fallecían por causa de las infecciones cruzadas y por el abuso de antibióticos y las incorrectas medidas de esterilización. En los meses de invierno las salas de niños con enfermedades respiratorias agudas y repletas de Bronquiolitis, reunían tantos pacientes en pasillos y en otros servicios que se cerraban a las afecciones quirúrgicas no urgentes y eran utilizados para cubrir los reclamos de los infantes con afecciones respiratorias. Ese hacinamiento de los hospitales repercutía en la recuperación de los enfermos, en este caso lactantes con Bronquiolitis y muchos fallecían. Esa era la realidad en el 1970 (5). Ahora esa no es la realidad, pues los pediatras especialistas, con excelente preparación trabajan en la Atención Primaria de Salud para promover y prevenir y también ofrecen atención médica y los pacientes no llegan a necesitar ingresos y en ocasiones se ingresan en el hogar. Variante de mucha utilidad en algunos países. I

Es necesario llamar su atención a la ruptura del binomio madre-hijo, en las consultas del Centro de salud o en salas hospitalarias, pues no siempre se escuchan sus opiniones y consideraciones.

Hoy se reclama al estudiante que empiece la pediatría (SANNA) desde las Universidades, “escuchar a la mamá” “solicitar a la mamá que nos diga, como lo encuentra hoy”. Claro que las

que sean madres me acompañarán a defender la importancia que tiene para el pediatra la opinión de la mamá.

Todo esto lleva a la reflexión sobre lo que se ha denominado atención integral, este término para todos debía ser colocado en paredes y en ventanas. Eso permitirá un diagnóstico más certero, y a la vez un acercamiento posibilitará una mejor atención basada en un diagnóstico integral y por ende el tratamiento será integral pues puede que se incluya un apoyo de otro miembro de la familia, para una pronta recuperación.

Es que la pediatría ni ninguna otra rama de la medicina es posible entenderla y mucho menos darle solución a los principales problemas de salud si no vemos a los niños niñas y adolescentes en el contexto real; dígase en el seno de la familia, del barrio y de la comunidad y ambiente que rodea ese paciente.

Existen enfermedades para cuyo diagnóstico se necesita un acercamiento a la vida familiar y en otros casos a los denominados antecedentes patológicos familiares y personales que pueden estar estrechamente vinculados. Una mirada a la mamá y a la niña de 9 meses permitió un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente: osteogénesis imperfecta. (6) La mamá tenía escleróticas azules y su niña también y la nena acudía por una fractura a una edad muy poco frecuente y sin mediar ningún accidente y es un antecedente familiar, pero no siempre se expresa. Esta y otras miles de enfermedades se transmiten de diferentes formas y su diagnóstico es importante.

Los motivos de consulta también pueden ser variados y ello es también parte de la integralidad con que se deben analizar las situaciones. Lo biológico, lo social, lo económico, lo del barrio, lo de la casa sin obviar que cada una de las aristas puede ayudar a darle solución al problema que aqueja al niño o al adolescente que acude a consulta. Muchas veces detrás de un adolescente que acude por cefalea, están enmascarados problemas de índole psicológico, o psico-social o familiar. No se logra identificar qué lleva a la cefalea; con mucha frecuencia se piensa en una hipertensión arterial, y ojalá siempre se pensara en ella, pues es un diagnóstico muy importante, pero no siempre se piensa en que hay un padre alcohólico o una madre, que es golpeada. Ojalá pueda siempre pensarse en las variadas causas de una aparente “sencilla consulta por cefalea”.

El entorno familiar y sus crisis que deben ser estudiadas por los pediatras, al igual que la estudian los médicos generalistas, estas crisis son causa de muchas de las dolencias por las que consultan niños de edad escolar, y otros aun menores, sin olvidar los adolescentes; el padre ausente física o emocionalmente, trae unido diversas situaciones a las que debe dar solución el pediatra.

La falta de visión familiar puede impedir que se tomen acciones para prevenir un nuevo embarazo de esa mamá, que acude a controles por su niño lactante, sin que se nos ocurra advertir a la madre acerca de las consecuencias de un nuevo embarazo; lamentablemente muchos recién nacidos de bajo peso se presentan por periodos intergenésicos cortos y la falta de percepción de riesgo de la madre

Es muy frecuente también olvidar al acercarse al año de edad explicarle a la madre y familia, los aspectos que no deben ser obviados entre ellos resalta el hablarle de los accidentes en el hogar, pero es responsabilidad dentro de la integralidad las acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades, curación y si fuera necesario rehabilitación.

Es por ello que el pediatra aun en una sala hospitalaria debe indagar sobre las vacunas que ya ha recibido el niño y pedir el cumplimiento del carnet de vacunación o de inmunizaciones. Esto en ocasiones se descuida y debe ser ocupación del pediatra, cualquiera que sea el escenario en el que se desarrolle. Actualmente hay tendencias modernas de no vacunar a los infantes, y ello es peligroso en la actualidad, se han desencadenado brotes de Sarampión, enfermedad que es prevenible por vacunas, por solo poner un ejemplo.

El pediatra integral además tiene la responsabilidad de la educación nutricional del bebé, con énfasis en que reciba lactancia materna pero va mas allá pues recientemente se destaca el rol de la alimentación desde el embarazo de la madre que según reportes determina la morbilidad por enfermedades crónicas en las y los niños (7) También debe velar por la incorporación de alimentos sanos y naturales siempre que sea factible, a partir de los seis meses y nunca antes de esta fecha. Se conoce que ello garantiza muchos nutrientes y además previene la anemia ferripriva y con una alimentación balanceada y sana se garantiza una mejor inmunidad y el niño

crecerá más saludable y tendrá sus mecanismos de defensa ante las diversas agresiones de enfermedades infecciosas.

El que las madres ofrezcan lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y complementada hasta los 2 años, no solo como alimento sino como un elemento vital en los primeros mil días de nacido (8) que le garantizan además de los nutrientes, el apego, el cariño, el contacto de lo que no debe ser privado por los peligros que trae la separación de la madre y la violencia en este período. Se le ha llamado estrés tóxico y ello es una pérdida a veces irreparable. También es parte de la integralidad y de responsabilidad con la salud del infante y su madre, que se vele por una curva de crecimiento y desarrollo acorde a su edad y sexo y se realicen acciones de fomento de alimentación sana, y medidas que estimulen la práctica de ejercicios físicos desde los primeros meses como recomienda la OMS (3) a inicios del 2019 ya citado y las necesarias horas de sueño, acorde a la importancia de estos dos aspectos en un mundo donde se violan los derechos elementales de un niño a jugar por descuido de los padres en cuanto a velar por el no uso abusivo de pantallas y de celulares a todas las edades sin debido control de sus riesgos o peligros para la salud.

La falta de estimulación del lenguaje a su debido tiempo y el control de la familia de los horarios de vida de los niños que deben ser inviolables, sus horas de sueño y vigilia, no olvidar el control de los esfínteres, que en los años de los pañales desechables se posterga un poco más de lo deseado y después cuesta horas el logro de hábitos de defecación y de otros aspectos propios de hábitos saludables.

En cada visita el pediatra debe explorar al niño de forma integral, no solo su peso y talla sino su dentición o cambios de la misma, su desarrollo psicomotor, su lenguaje, sus expresiones, su capacidad de escuchar y de expresarse, sus logros antes y al llegar la escuela, sus progresos en las diferentes asignaturas, su vida social con el grupo. Si lo miramos siempre desde la cabeza a los pies, desde pequeñines hasta adolescentes hay que mirarlo, observarlo, inspeccionar, palpar, auscultar, diagnosticar, siempre con una mirada integral de lo biológico y lo social en lo individual y en lo familiar y en lo comunitario.

Reconocer todas las potencialidades y prevenir desde el primer día de nacido. Su futuro está en

nuestras manos y debemos estimular al niño a auto cuidarse, a practicar la ayuda mutua, cuidar su ambiente escolar, familiar, comunitario, su hogar y su entorno.

Promover salud con educación para la salud y participación de las comunidades, prevenir las enfermedades, curar y rehabilitar. Todo ello en las diversas esferas, ya sea biológicas, psicológicas, económico social y tanto en lo individual como en lo familiar y comunitario.

Con una sonrisa, una escucha atenta, un consejo y una adecuada observación con un examen físico integral, minucioso y de calidad; en resumen muy atentos a lo que nos ofrezca una alerta para conocerle mejor, sin obviar el rol de la familia y del entorno de manera que podemos contribuir a una atención integral de óptima calidad.

Referencias bibliográficas

1. Martí J. *Obras Completas de José Martí* 1883
2. Epp J. *Lograr la salud para todos: un marco para la promoción de la salud*. En: Organización Panamericana Salud. *Promoción de salud: una antología*. Washington D.C.: OMS; 1996. p. 352-64. Jake EPP
3. OMS *Nuevas directrices de la OMS sobre actividad física, sedentarismo y sueño para menores de 5 años* abril 2019 Who.int disponible en <http://www.who.int>
4. Monsalvo J. en Carta 420:05/2020 *Relaciones saludables con el aire* disponible en <http://www.altalegremia.com.ar>
5. Ministerio de Salud Pública. *Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadística de Salud. Anuario Estadístico de Salud*. La Habana: MINSAP; 2018.
6. Herreros MB, Franco R1, Ascurra M2. *Las Ontogénesis Imperfectas Revisión tema Pediatr(Asunción) Vol 35;N 1;2008* disponible en SciELOv35n1a07.pdf
7. Moreno-Villares Jose-Manuel, Collado Maria Carmen, Larque Elvira, Leis Trabazo Maria Rosaura Sáez Los primeros 1000 días: una oportunidad para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles *Nutrición Hospitalaria versión online* disponible en www.SciELO.iscili.es (2019)
8. Quinteros G *El Recién nacido los primeros 1000 días de vida* Disponible en <https://www.sap.org.ar>
9. *Manejo respetuoso del llanto*. www.crececontigo.gob.cl
10. Barton D. Schmitt M.D *Cólico: llanto excesivo en el recién nacido* *Clínicas de Perinatología*
11. Brazelton T.B. *Crying in infancy Pediatrics* 29-579-588 1962
12. Quintero E.J *Lactancia materna. Regalo de vida ¡ mejor para todo!* Editorial Feijoo
13. OMS-OPS *Manual de consejería en lactancia materna Manual de capacitación* 1999

*Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites

Graduada en Doctora en Ciencias de la Salud en la EN-SAP (Escuela Nacional de Salud Pública) La Habana. Cuba (PhD)

Doctora en Medicina (1969) Universidad Central de Las

Villas Especialista de Primer Grado en Pediatría (1975) y Especialista de Segundo Grado en Pediatría (1986) Magister en Atención Primaria de Salud (2000) (ENSAP). La Habana. Cuba.

Profesora Consultora y Titular de Pediatría que ha contribuido a la formación de médicos desde hace 50 años y a la formación de especialistas en Pediatría y en MGI en la Provincia Villa Clara. Se ha desarrollado como docente de Pediatría y más tarde de Medicina General en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

Ha realizado asesorías en varias provincias de Argentina desde hace 20 años y en los últimos años en la UNMdP en el ámbito de la nueva Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata (2017 -2019).

Experiencia en docencia de post grados internacionales desde 1994 (25 años) “Nuevos enfoques y métodos en Atención Primaria de Salud”.

Profesora Universitaria, con vínculo estrecho en la formación y perfeccionamiento de los recursos humanos para implementar la Estrategia de Atención Primaria de Salud, como parte de la Renovación de esta estrategia para Las Américas.

Evaluadora de la primera carrera de Medicina de Cuba con la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del MES de Cuba en 2004 y en otras carreras en Cuba en Ciudad La Habana y Camaguey.

CUIDARÁS LA SALUD INFANTIL. SALUD ESCOLAR EN ESCUELA RURAL DE HINOJO



SILVINA ALCAZA
FIORELLA BIANCHI
GONZALO CABOT
PABLO CÁCERES
LORENA CAMINOS
MARÍA FE CARREIRA NETO
JUAN EMILIO CIANCIO
NERINA CÓRSICO
MICAELA FÍGARO
VICTORIA GÓMEZ ROLDÁN
LISANDRO LEÓN
SOFÍA PORTA
VICTORIA RAMOS
MARÍA DE LA PAZ SEDANO
PAULA VILATI

COORDINACIÓN GENERAL:

MICAELA FÍGARO

COLABORADORES:

MANUEL ACOSTA / LOANA CISNEROS/
 SALVADOR CONSALVO/ JOAQUINA DA
 SILVA/ DAIANA FERNÁNDEZ/ BERNABÉ
 HERRERA/ MACARENA JUÁREZ/
 KEVIN LAZARTE/ CAROLINA QUINTEROS

EXPERTOS CONSULTADOS:

DR. JUAN REICHENBACH
 DR. HÉCTOR TREBUCQ
 DR. CARLOS PREGO
 Lic. MARIA LAURA CATALANO
 DRA. ROSANA GABRIELA DELLA
 MAGGIORA
 DRA. MARÍA ESTHER GATELLA
 DR. GASTÓN SEAMBELAR
 ING. DANIELA PENA

Se agradece la especial colaboración al Dr. Prof. Juan Reichenbach, quien nos incentivó y dirigió en este proyecto. Agradecemos su colaboración, sus vivencias, sus experiencias, que tanto nos acompañaron y enriquecieron.

Y destacamos las ideas, la ayuda, la compañía, el conocimiento, la guía, las anécdotas, las investigaciones, los números, y tantas cualidades más que nos permitió conocer, y que realmente hicieron posible este trabajo.

A las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, Decano Dr. Héctor Trebucq y Vicedecano Dr. Carlos Prego, por apoyarnos y facilitarnos el contacto con la escuela y profesionales del Hospital Municipal Héctor Cura. También queremos agradecer a todos los profesionales de la salud

que se pusieron a disposición para guiarnos y derivar consultas: Lic. Laura Catalano, especial agradecimiento por su compañía, aliento y ayuda en cada encuentro, Dra. María del Carmen Weis, Dr. Gastón Seambelar. Dra Rosana Gabriela Della Maggiora. Finalmente, agradecer la importante colaboración de los directivos y equipo docente de la Escuela de Educación Primaria Nº 11 de la localidad de Hinojo, por el compromiso, respeto y completo apoyo incondicional para la realización de este trabajo.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

Sumario

Experiencia integral de salud escolar realizada en una escuela de Hinojo a pocos km. de Olavarría. Dirigida por expertos y especialistas y concretada por estudiantes supervisados de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría, UNCPBA, UNICEN. Un ejemplo de la importancia de las facultades en el terreno de la APS y la equidad.

Fundamentación

La función de la escuela es capacitar y brindar información necesaria a los niños para que ellos, en base a sus posibilidades, desarrollen las capacidades requeridas para enfrentar la vida, no sólo respecto a lo académico, sino también su formación integral, entendiendo que vivirán en un mundo con personas diferentes con las que construirán su futuro.

Un gran aspecto de esto es la salud, entendida como “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”, con lo cual, la escuela es gran partícipe en esta situación, y para el buen desarrollo de los niños es necesario que estos dos aspectos vayan de la mano.

Al trabajar con la salud escolar, se beneficia no sólo a los niños en contacto directo, sino que indirectamente, los beneficios llegan a la sociedad en general, la familia y la comunidad. Todo el esfuerzo que se enfoque en incrementar la asistencia escolar y mejorar la calidad de vida en la niñez debe involucrar a padres, tutores o responsables sociales.

La función de este proyecto “CUIDARÁS al Niño”, es dar a conocer la importancia que significa fomentar la promoción y prevención de la salud en la escuela, como una manera de prevenir enfermedades, de disminuir riesgos, evitar accidentes, resolver problemas de salud, y enseñar la importancia del autocuidado. Esto será relevante no sólo en el presente, ya que evita ausencias de los niños a clase y mejora el rendimiento escolar, sino también, en el futuro, para lograr un buen crecimiento, con óptimo desarrollo físico, mental y emocional.

El trabajo debe ser interdisciplinario, con igual responsabilidad de cada una de las partes, e iguales oportunidades de llevar a cabo las tareas a realizar.

Durante la niñez, es fundamental no perder oportunidades y detectar alteraciones si las hubieren, para que de esta forma, se eviten complicaciones en el futuro y se pueda lograr el crecimiento y desarrollo que se espera para el niño.

La escuela es un vínculo para fomentar el cuidado de la salud, por consiguiente, es indispensable el aula como medio o canal necesario para la promoción de la salud.

Marco teórico

En los controles de salud se recibe información general y actualizada, que ayuda a reconocer riesgos, necesidades, composición familiar, situación socioeconómica (funcionamiento familiar, datos socioeconómicos, factores protectores y de riesgo), habilidades de los padres, cuidados básicos, redes de apoyo social.

El control de salud o control del niño sano (CNS) es hoy, en algunos sectores de la población, el motivo de consulta más frecuente en los niños. El CNS se produce en un marco distinto al del adulto. Los niños son pacientes básicamente sanos; es decir, la mayoría de ellos sólo son llevados al médico para controlar el crecimiento o para resolver problemas autolimitados.

Los principales objetivos del control de salud son:

- Realizar una evaluación física que permita detectar patologías en forma temprana.
- Evaluar el crecimiento y el desarrollo para detectar alteraciones que puedan modificarse mediante la intervención médica.
- Realizar prácticas preventivas (vacunación, vitaminas, etc.) y rastreo de entidades mórbidas.
- Orientar y educar a los padres en el cuidado del niño y en la prevención de los problemas de salud.
- Detectar y ayudar a resolver diferentes situaciones que puedan comprometer el desarrollo normal del niño (crisis patológicas, límites, conflictos entre los padres, violencia, etc.)

Es por ello que, en los años '50 con el surgimiento de las especialidades médicas, la atención de los niños pasó a ser materia exclusiva de los pediatras, y que anteriormente estaba abocada a los médicos de familia.

En muchos países, los niños concurren periódicamente a centros de salud (sobre todo en el primer año de vida) en los que se controla el ca-

lendario de vacunación, se evalúa el crecimiento para detectar en forma temprana la desnutrición y otras patologías, se detectan malformaciones y otras enfermedades, etc.

La periodicidad de dichos controles según edad de vida es la siguiente: 1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 2 años, 2 ½ años, 3 años y finalmente una visita por año hasta cumplir los 21 años.

Los controles son de gran importancia para asegurar un crecimiento satisfactorio, por lo que distintas áreas del campo de la salud se dedican a estudiar su influencia en el crecimiento de los niños. Asimismo, esto va de la mano de la Atención Primaria de la Salud (APS), y de las políticas de salud pública.

Estas políticas de promoción de la salud, desarrollan un papel fundamental en las prácticas concretas que se realizan en el ámbito de la APS. Las prácticas pediátricas giran en torno al encuadre propuesto por dichas políticas de implementación internacional, nacional, provincial y municipal.

Metodología y técnicas

Para el presente trabajo se procedió a contactarse con la escuela próxima a ser sujeta de estudio. Las autoridades de ambas instituciones, la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y la Escuela Primaria N° 11 de la localidad de Hinojo, llegaron a un acuerdo que permitió a los estudiantes llevar a cabo dicho proyecto, “CUIDARÁS al Niño”.

La Escuela Primaria N° 11, es una institución que pertenece al ámbito rural de índole estatal. El establecimiento posee una modalidad especial de inclusión, brindando un espacio de integración e igualdad para todos sus alumnos. La misma se encuentra ubicada en la localidad de Hinojo, a 19 km de la cabecera Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

En un primer momento, se realizó un encuentro con los alumnos de primero, segundo y tercer año de la escuela, para explicarles a los niños acerca nuestro proyecto, y también, entregarles una planilla a completar (además de otro anexo específico para conocer los datos socioeconómicos y culturales de cada hogar) obtenida del programa PROSANE (Programa Nacional de Salud Escolar) en donde figura el consentimiento informado a los padres para el examen físico

de sus hijos y así, obtener información acerca de antecedentes personales y familiares de los menores.

Un segundo encuentro se llevó a cabo para la revisión de libretas sanitarias, donde se registró en las planillas de cada alumno, el nombre, apellido y curso al que pertenecía el niño. El objetivo fue controlar el cumplimiento del calendario de vacunación según las edades correspondientes.

En el tercer encuentro se realizaron los primeros controles de niño sano, con distintas estaciones: peso y talla, toma de presión arterial, examen de agudeza visual y examen físico completo. En este encuentro se revisaron a los niños de primer año, y en los encuentros posteriores se prosiguió con segundo y tercero.

El examen físico realizado en el marco del PROSANE, no debe diferir del que se realiza de rutina a niños, niñas y adolescentes en el centro de salud.

En “CUIDARÁS al Niño” el examen físico fue realizado en la escuela, donde se puso hincapié en la preparación de un ambiente adecuado de privacidad y confort, para que los niños se sientan cómodos y relajados, con suficiente espacio permitiendo la observación en posición sentada y en decúbito dorsal.

La guía PROSANE utilizada para realizar el examen físico fue orientada a la detección de signos que podrían corresponder a distintas patologías, facilitando la toma de decisiones en terreno para su resolución. Dichos signos, cumplen los criterios de magnitud o frecuencia, gravedad y posibilidad de intervención a través de prevención primaria, secundaria y de eventuales secuelas, como también, el impacto social e individual.

Examen físico

Vacunación:

La vacunación es una de las principales medidas preventivas para evitar enfermedades que pueden ser graves para nuestra salud, es un derecho y una obligación. Está demostrado que a través de esta medida se pudieron controlar enfermedades infectocontagiosas a partir del calendario de vacunación de manera gratuita y obligatoria.

Los programas de vacunación son de bajo costo en relación a los beneficios que logran y además son una herramienta de equidad, llegando

a todos los niños de los diferentes estratos sociales. Además, son un elemento de solidaridad y de responsabilidad colectiva, porque cuando el individuo se vacuna, también reduce el riesgo para quienes interactúan con él, incluso no vacunados ya que éstas, constituyen un riesgo para sí mismas y para quienes las rodean.

En nuestro país el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución Nacional, tratados internacionales a los que hemos suscripto (como la Convención de los Derechos del Niño) y por disposiciones legales tanto de los ámbitos nacionales como provinciales.

La Ley Nº 26.061 en su artículo 14 hace referencia a que... “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud...y acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz tratamiento oportuno, y recuperación de la salud”.

Por otro lado, la Ley Nº 22.909 / 1983 menciona en el art. 11: “las vacunaciones incluidas en el Calendario Nacional son obligatorias para todos los habitantes del país”. De esta manera, implementa una política preventiva y establece un criterio obligatorio de protección. Son los organismos del Estado quienes deben garantizar la posibilidad del cumplimiento efectivo de estos derechos. 1

Se inspeccionó las libretas sanitarias de 101 alumnos pertenecientes a los primeros 3 años. Se observó la presencia completa del esquema de vacunación de la República Argentina, el cual es ofrecido de manera gratuita y obligatoria. En este caso las correspondientes con la edad son: BCG, Quíntuple (DTP Hib HB), Antineumocócica, IPV / OPV, Antigripal, Anti Hepatitis A, Triple/Doble Viral y Triple Bacteriana acelular (dTpa).

Agudeza visual:

La visión es una función sensorial evolutiva. Como sentido, facilita el desarrollo motor, intelectual; el lenguaje, el aprendizaje y la relación del niño con el medio que lo rodea. El examen oftalmológico básico debería estar incluido desde la primera consulta en todos los niños, tan pronto como sea posible, debido a la importancia de la detección temprana de patologías oftalmológicas pediátricas.

Durante la evaluación se utilizaron las cartillas de Snellen y el Test de Pigassou, donde los infantes podían optar por una u otra, depen-

diendo de su edad y su nivel de aprendizaje. En primer lugar, se realizó un interrogatorio para indagar sobre el uso de lentes, luego se procedió a sentar al niño a una distancia aproximada de tres metros frente a la cartilla bien iluminada. Se continuó ocluyendo el ojo izquierdo para examinar el derecho a través de un oclisor en forma de triángulo; repitiendo el procedimiento con el ojo izquierdo. En el caso de la utilización de lentes, los mismos eran requeridos a la hora de la evaluación. Se solicitó que lea en voz alta las letras/figuras señaladas al azar por el examinador, desde las de mayor tamaño hasta las que el niño era capaz de reconocer, siendo este último renglón el determinante de la agudeza visual de ese ojo. Finalmente, se registraba en forma de fracción (10/10) los resultados obtenidos en cada caso, clasificándolas según fuera visión normal (9/10), moderada (7-8 /10) y severa (menor a 6).

Neumología:

El sistema respiratorio tiene la función de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono que se produce en todo el cuerpo mediante la respiración, la cual es un proceso involuntario donde se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsa dióxido de carbono en el aire espirado. Los órganos que llevan a cabo este proceso son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. Este sistema resulta indispensable para la vida.

El CNS es imprescindible para la prevención, detección y diagnóstico precoz ante las enfermedades de mayor prevalencia respiratoria en pediátricos, desde su nacimiento continuando a los siete días, luego a los quince días, treinta días, todos los meses hasta el año, cada dos meses hasta los dos años y todos los años hasta los diez años, completando así el esquema de los controles necesarios para el óptimo desarrollo psíquico, físico y mental.

Se realizó un examen físico de manera ordenada según el manual PROSANE donde se les pidió a los niños permiso para realizar una inspección general del estado del tórax en cuanto a la estática, en forma y tipo, asimetrías, y en dinámica a frecuencia, ritmo, esfuerzo respiratorio, amplitud y relación inspiración-espiración. En la palpación se intentó localizar inflamación, puntos dolorosos, enfisemas subcutáneos; también se realizó la palpación de roncus y amplexación

para valorar la elasticidad del tórax. A través de la percusión, se logró apreciar el contenido de aire en los tejidos a partir de la vibración, y matidez en caso de derrames y/o condensaciones. Mediante la auscultación, se escuchó la ventilación y los ruidos accesorios, para comparar puntos simétricos en ambos hemitórax.

Tensión arterial:

En la práctica se utiliza la medición indirecta de la presión arterial (PA), dada la sencillez de la técnica y el fácil acceso. El valor obtenido se utiliza para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial (HTA). La medición indirecta de la PA es segura, indolora y provee información confiable y objetiva cuando se realiza correctamente. La clasificación de la presión arterial en pediatría se basa en los percentiles de PA según sexo, edad y talla. Se utilizan para la categorización, las tablas americanas actualizadas que han excluido con respecto a las anteriores, los valores de PA de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Se recomienda efectuar la medición de la presión arterial como parte del

control de salud a todos los niños y niñas a partir de los 3 años y en los menores de 3 años con sospecha o diagnóstico de enfermedades asociadas a HTA.

En este trabajo se realizaron mediciones arteriales a niños/as entre 6 y 8 años.

El procedimiento de la toma de la PA se realizó en un ámbito adecuado en el cual los alumnos se sintieran cómodos y tranquilos, demostrándoles que el procedimiento no causaba dolor. Para la correcta toma de PA lo primero que se tuvo en cuenta fue la dimensión del manguito ya que esta depende del tamaño del niño y no de su edad. El manguito debe rodear completa y cómodamente el brazo del niño, y cubrir tres cuartas partes de la longitud del brazo.

Una vez que el niño/a estaba listo y en una posición cómoda (sentado), se colocó el brazo extendido sobre una mesa a la altura del corazón. Las cifras obtenidas fueron anotadas en la planilla de cada alumno, registrando el valor sistólico y diastólico.

Por último, se trabajó con la tabla de percentiles, se analizó de manera individual cada alumno, utilizando como dato la talla en centímetros (cm) y el valor de presión arterial tanto sistólico como diastólico.

Dermatología:

Las causas dermatológicas suponen un motivo habitual de consulta en Pediatría de Atención Primaria y reflejan tanto la frecuencia de éstos, como la manifiesta preocupación de los padres por dichos problemas, que afortunadamente no suelen ser graves. Pero esta situación incide tanto en AP como en Atención Hospitalaria, sin olvidar los servicios de urgencias pediátricas, de ahí que el pediatra esté necesariamente obligado a incorporarlos a su práctica diaria y a contar con recursos y habilidades para su manejo. Tal aproximación a los problemas dermatológicos requiere conocimientos, actitudes y habilidades adicionales por parte de los profesionales dedicados a la atención pediátrica.¹

Durante todo el estudio se contó con el apoyo de especialistas en dermatología de nuestro hospital de referencia (Hospital Municipal Doctor Héctor M. Cura) para solventar dudas diagnósticas y poder consultar en caso de que la situación así lo recomendase o bien para una posible derivación.

Con respecto al examen clínico, se le explicó a cada niño qué realizaríamos, cómo y para qué.

Hipertensión arterial en niños	
NORMAL	<90 percentilo de la edad
ALTA NORMAL	>90, 95<percentilo para la edad (salvo exceso de peso o talla) Hacer promedio de 3 lecturas diferentes
HIPERTENSIÓN SIGNIFICATIVA	>95, 99<percentilo para la edad Hacer promedio de 3 lecturas diferentes
HIPERTENSIÓN SEVERA	>99 percentilo para la edad Hacer promedio de 3 lecturas diferentes

La información, da tranquilidad a los niños y su familia. Dentro de él, incluimos la observación de piel y faneras, y los casos derivados al servicio de dermatología fueron un total de 4.

Odontología:

La salud bucal es esencial para una buena calidad de vida y bienestar personal. La educación y el mantenimiento de la misma en la primera infancia es de suma importancia para prevenir tempranamente cualquier alteración en el crecimiento y desarrollo bucodental, así como también las caries. La Academia Americana de Odontología Pediátrica define la caries de la infancia temprana (CIT) como la presencia de uno o más dientes cariados (cavitados o no), ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria. La maloclusión y alteraciones en la posición de piezas dentales presentan posibles alteraciones en la mordida que puedan necesitar un tratamiento ortodóntico, por lo que su precoz hallazgo resulta de suma importancia.

Se realizó dentro del examen físico una inspección general de la salud bucal, buscando posibles problemas o anomalías en las piezas dentarias y la mordida.

Evaluación antropométrica:

En los primeros años de vida, es necesaria una alimentación adecuada para el mantenimiento de las funciones orgánicas, el crecimiento y el desarrollo normal del niño. Si el organismo no recibe las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas nutricionales como la anemia y la desnutrición; si se ingieren en exceso se producen alteraciones como la obesidad, la cual tiende a estar asociada con enfermedades crónicas degenerativas tales como la diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares.

La satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes, a través de la ingestión de una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales que intervienen en los procesos de crecimiento, desarrollo y en la reparación de los tejidos.

La estatura de los niños y niñas y su ritmo de crecimiento se ve afectado por diversos factores genéticos, hormonales, ambientales y especialmente nutricionales, que interactúan desde el momento de la concepción hasta el final de la pubertad.

El crecimiento de cada niño y niña tiene características individuales. La medición periódica de peso y talla es uno de los procedimientos para establecer si están dentro de los límites normales para su edad y sexo.

En la etapa preescolar y el inicio de la etapa escolar, el crecimiento es lento pero continuo y es más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y calidad de los alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias nutritivas que necesitan.

En el examen físico se realizó una evaluación antropométrica según las indicaciones del Manual PROSANE. Las medidas básicas consideradas fueron el peso y la talla, a partir de las cuales se construyeron 3 indicadores:

- El peso para la edad y sexo
- La talla para la edad y sexo
- El IMC para la edad y sexo

Los indicadores que fueron utilizados para realizar la categorización nutricional fueron la talla para la edad y sexo y el IMC para la edad y sexo.

Para calcular el peso de cada niño/a se utilizaron balanzas digitales y para la medición de la talla se utilizó un pediómetro con el previo consentimiento informado escrito de sus responsables legales.

Una vez realizado el control del peso y la talla, se calculó el IMC. Para realizar la categorización nutricional se compararon todos los valores obtenidos con las tablas de referencia para edad y sexo, para ubicar el percentilo o puntaje Z en el que se encuentra el niño/a.

Resultados

Mediante el examen físico realizado a los alumnos de 1°, 2° y 3° grado de la escuela, dieron los siguientes resultados a cada especialidad médica.

En cuanto a la vacunación, se deduce que, de la muestra estudiada (101 libretas), sólo el 75 % de los participantes contaba con una libreta de vacunación completa, y el 25 % restante no tenía constancia de tener completos los esquemas de vacunación; el cual se consideraba incompleto con sólo la ausencia de dosis o refuerzo, por lo tanto, se consideraron con calendarios incompletos a aquellos participantes que no tenga una dosis de antigripal. No consideramos la falta de vacunación contra el rotavirus (corresponde a nacidos a partir del 01/01/2015), el menin-

gococo (nacidos a partir 1/10/2016) y la varicela (para nacidos a partir del 01/10/2013, lo cual no le correspondería de manera obligatoria. Éstas, junto con la vacuna del virus de la Hepatitis A, y la neumocócica fueron las principales vacunas ausentes en estos niños. Se observaron retrasos de hasta 1 año en los calendarios, y únicas dosis que no representa al esquema correspondiente. Gran mayoría de los calendarios de las libretas sanitarias estaban desorganizados y atrasados. Además, observamos que el 17% de los participantes contaban con 3 o más dosis de antigripal, incluso más de 4 dosis de neumocócica, por lo que inferimos que estos participantes tienen factores de riesgos para enfermedades respiratorias. (Ver Gráfico N°1)

Consideramos que puede haber sesgos ya que estos datos fueron recopilados por múltiples participantes, y muchas de las libretas estaban rotas, ilegibles o incluso con hojas faltantes.

Al referirnos al examen de agudeza visual, se observó que, de las 110 planillas evaluadas, el 23% de los infantes tienen una visión disminuida en torno a lo normal. Las causas pueden ser por errores de refracción no corregidos, cataratas, entre otras que podrían haber sido previstas anteriormente si los niños se hubiesen realizado controles oportunamente. (Ver Gráfico N°2)

Con respecto al examen de neumonología, todos los resultados obtenidos fueron completados en las planillas correspondientes de cada sujeto con el nombre, la autorización, el curso y datos adjuntos acerca de los determinantes socio-económicos y ambientales, además de los antecedentes familiares e individuales. La información obtenida corresponde a 110 planillas, de las cuales el 22,7% de los alumnos refirieron tener antecedentes de espasmos bronquiales, asma a repetición y hallazgos en el examen físico.

El hallazgo más relevante del examen físico fue el 22% de casos con espasmos e hiperreactividad bronquial, de los cuales el 3,6% fueron casos derivados al segundo nivel de atención. (Ver Gráfico N°3)

Continuando con la toma de tensión arterial, de los 110 niños examinados se detectó que el 19,26% tenía valores de PA elevados, de los cuales el 38,8% fueron niños y el 61,2% fueron niñas. Evaluando la distribución por cursos resultó que el 50% de los casos fueron de 2º año, mientras que el 27,7% correspondieron a 1er año y el

22,3% a 3ro. Entre los chicos que presentaron valores de TA elevados se observó que el 27% habían sido diagnosticados con asma previamente y el 11% nacieron prematuros. Además se detectó que un 55% de los niños con PA elevada presentaban obesidad y un 11,1% sobrepeso de acuerdo a la medida de IMC ajustada por edad y sexo. Sumado a esto resulta relevante aclarar que un 40% de los niños con obesidad no realiza actividad física. En un 11% de los casos se detectó tabaquismo en los hogares de los niños siendo esto investigado a través de una encuesta, lo cual da la posibilidad de que este porcentaje sea mayor. (Ver Gráfico N°4)

Las mediciones de presión arterial evidenciaron que de los casos de PA elevados:

- El 55,5% correspondió a $> P90$ a $< P95$
- El 38,8% correspondió a $> P95$ a $< P95 + 12\text{mmHg}$
- El 5% correspondió a $> P95 + 12\text{mmHg}$

En el examen dermatológico, siguiendo la planilla del PROSANE, se prosiguió a detallar, en caso de hallazgos relevantes (correspondientes al 7,27% del total de 110 niños), la impresión diagnóstica de cada uno: Del total de niños con dichos hallazgos (7,2%), el 25% presentó pediculosis, mientras que sólo 1 niño presentó escabiosis (12,5%). Respecto a otros hallazgos relevantes encontrados, sólo 1 niño (12,5%) presentó palidez cutáneo-mucosa en palmas y falanges (correspondiente a un síndrome clínico de malnutrición). Otro niño presentó “manchas” en tratamiento, mientras que otros dos presentaron “placas” y verrugas respectivamente, sin referir tratamiento de las dichas. Cabe destacar la ausencia de Lesiones Compatibles con Maltrato (LCM) y piodermitis. (Ver Gráfico N°5)

La información obtenida a odontología corresponde a 110 planillas, de los cuales se encontró que sólo uno de los alumnos padece de maloclusión, la cual ya se encontraba con su debido tratamiento. Además, se observó en un 16,3% de ellos, la presencia de caries en piezas dentales temporales. El 16% de la muestra presentaban caries en su dentición permanente.

Otro hallazgo importante fue que al discriminar los alumnos según el año escolar y relacionarlos con la presencia de caries, se evidenció un crecimiento del porcentaje de niños que padecen la infección en los años escolares más altos. En el primer grado el porcentaje de alumnos con

caries (14%), resultó menor que el de segundo grado (36%) y del de tercero (26%). (Ver Gráfico N°6)

Por último, aun así no menos importante, la concentración de resultados de la evaluación antropométrica de los 110 niños fue analizada con el software OMS Anthro Plus. Posteriormente fueron comparados con los datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas a la familia de cada niño/a. Este software consta de tres partes: una calculadora antropométrica, un módulo que permite el análisis de mediciones individuales de niños y un módulo para el análisis de datos de encuestas de poblaciones sobre el estado nutricional.

De un total de 107 niños/as, de los cuales 51 (47,6%) son mujeres y 56 (52,3%) son varones, se concluyó que 49 (45,7%) mantienen un peso normal (24 niñas y 25 niños), 21(19,6%) tienen sobrepeso (7 niñas y 14 niños) y 35 (32,7%) presentan obesidad (17 niñas y 18 niños) y se encontraron 2 (1,8%) niñas con riesgo de bajo peso. Con respecto a la talla, 100 niños/as se encuentran dentro de los percentilos normales para la edad, de los cuales 47 (43,9%) corresponden a las niñas y 53 (49,5%) a los niños. Del resto, 6 (5,6%) mantenían una talla por arriba de la media para su edad (3 niñas y 3 niños), y se detectó 1 niño con baja talla. (Ver Gráfico N°7)

De los niños obesos, 3 (2,8%) presentaban talla por encima del percentilo 97. De las niñas con talla por encima de este percentilo, 2 presentaban sobrepeso y 1 obesidad.

El niño con baja talla presentaba un peso normal para su edad.

Por último, las 2 (1,8%) niñas con riesgo de bajo peso, presentaban una talla dentro del percentil normal para su edad.

En conclusión, podemos identificar que un poco más de la mitad de los niños/as (56 en total) tiene tendencia hacia pesos más altos que los acordes a su edad, superando a los 49 que presentan un peso normal. Esto podría deberse a los hábitos alimentarios que mantiene cada niño/a y la falta o no de actividad física.

Por último, se aclara que los posibles sesgos que contenga el trabajo tienen como fundamentos: la ausencia a clase el día de la evaluación, la negativa de los padres frente al consentimiento, e incluso de quienes se obtuvo consentimiento informado algunos no completaron datos necesarios de las planillas para la evaluación. El total

Gráfico N°1
Calendario de Vacunación

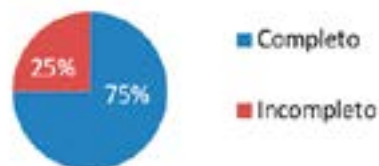


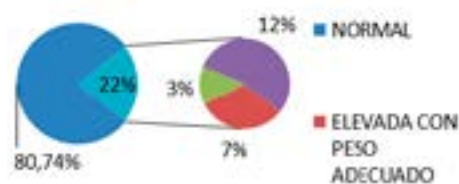
Gráfico N°2
Agudeza Visual



Gráfico N°3
Antecedentes Neumonología



Gráfico N°4
Tensión Arterial



de niños en un principio fue de 110, y ese número disminuye poco notable según estos factores a la hora de analizarlos.

Gráficos: la representación con gráficos da la posibilidad de una interpretación rápida y abreviada de los resultados a los que se llegaron. La fuente de los siguientes gráficos es la investigación del equipo. Fecha: 2019-2020.

Discusión

Los resultados muestran una población con falta de accesibilidad al sistema de salud, esto se da por distintos factores. Lo real es que se denota una falta de controles de niño sano en un porcentaje alto de la población sujeto.

El que no se realicen controles puede estar vinculado a las diversas barreras de accesibilidad que se encuentran en dicha localidad, entre las cuales se identifican las geográficas y económicas, estas incluyen los medios de transporte público y sus costos, o las distancias a pie que las personas deben recorrer para llegar al servicio de salud, muchas veces con terrenos llenos de obstáculos. Otros factores son administrativos, tales como, la organización de los servicios y sus modalidades administrativas, que a veces impiden el acceso al servicio y la atención oportuna, incluyendo los horarios de entrega de turnos y horarios de administración y la solicitud de exámenes complementarios en diferentes sectores y días. Se considera también la falta de profesionales en el servicio de salud brindado por el estado en la localidad de Hinojo, que imposibilita una atención favorable para las necesidades oftalmológicas impuestas por los pacientes.

Otros resultados obtenidos pueden estar vinculados a factores de riesgo siendo estos, determinantes necesarios pero no suficientes para el proceso de salud-enfermedad de los niños, lo cual es imprescindible tenerlos en cuenta, ya que conociendo el contexto en que cada niño crece y se desarrolla, uno puede llegar a un diagnóstico antes que la enfermedad se establezca, permitiéndose una verdadera prevención de la salud y diagnóstico oportuno, así se comprende al modelo salud-atención-cuidado como un proceso en el cual la comunidad asume la responsabilidad y participa para el bienestar y el cuidado de su salud.

Con respecto a la evaluación antropométrica específicamente, en esta etapa de la vida, debi-

Gráfico N°5
Dermatología

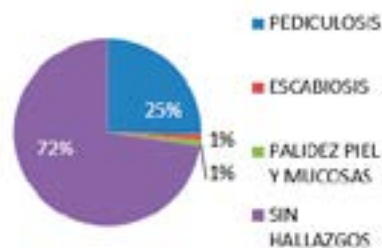


Gráfico N°6
Presencia de Caries

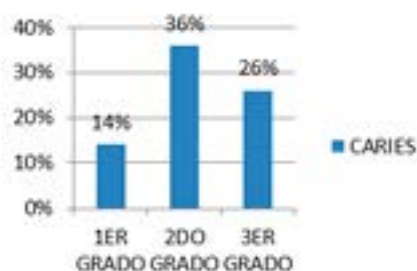
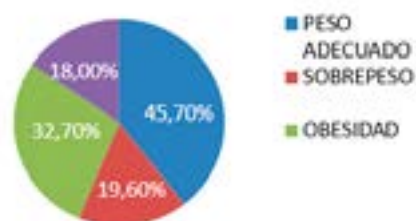


Gráfico N°7
IMC



do a la mayor independencia y la influencia de su familia y/o pares, con frecuencia toman decisiones equivocadas respecto a los alimentos que deben comer, por ejemplo: desayunos escasos, de baja calidad o ausencia de este tiempo de comida; almuerzos insuficientes o mal seleccionados, sobre todo cuando se consumen fuera del hogar y la elección de los alimentos queda a criterio del niño; meriendas donde el tipo de alimentos preferidos son productos de poca o nula calidad nutricional.

Por estas razones y otras que afectan directamente su salud, existen muchos escolares que se han quedado con baja talla para su edad y

también la existencia de niños con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, es necesario que los adultos les enseñen a seleccionar y combinar los alimentos para lograr una alimentación que permita un desarrollo y crecimiento adecuado.

Conclusiones

Las conclusiones a las que aborda el equipo de trabajo concuerdan con la fundamentación del mismo. La Salud Escolar es de primera necesidad en un país con nuestras características, donde los niños son realmente el futuro, y se están gestando en inequidades e injusticias del presente.

Los resultados permiten la interpretación de la Atención Primaria de la Salud, de la salud escolar, de la salud pública como el eje principal de las estrategias y políticas públicas, permitiendo a los niños de hoy que se formen y desarrollen con aptitudes necesarias para lograr una vida saludable y óptima. Es realmente importante que la salud pública se articule con la educación, invirtiendo en promoción y prevención de la salud, esto evita complicaciones a futuro en los niños, y analizado desde el aspecto económico para un país, permite disminuir gasto público en enfermedades crónicas.

El equipo se encontró con una realidad que se repite en muchos puntos de nuestro país, las dificultades que trae la centralización del sistema de salud: aun estando a pocos kilómetros del segundo nivel de atención, para la mayoría de la población resulta de difícil acceso, se crean oportunidades perdidas, se dificulta el acceso de nuestros niños y de sus familias, no se realizan seguimientos de tratamientos y muchas veces, no se llega a diagnósticos certeros.

Se refuerza la necesidad imperiosa de médicos generalistas, médicos clínicos, pediatras, ginecólogos en las comunidades pequeñas, tal es el caso de Hinojo, para hacer hincapié en la importancia de la prevención y promoción de la salud. Para tener seguimiento clínico de las familias de la comunidad, y así obtener diagnósticos tempranos, tratamientos efectivos y crear hábitos saludables.



Escuela N°11 – HINOJO, Olavarría. 2019 – EQUIPO DE TRABAJO.



Examen Visual – Niños de 1er a 3º grado. Escuela N°11 – HINOJO, Olavarría.



Evaluación antropométrica



Examen Cardiovascular y Respiratorio



Evaluación abdominal



Evaluación odontológica



Toma de tensión arterial en una de las estaciones



Evaluación dermatológica

Bibliografía

Ballesteros M. *Las barreras en el acceso a los servicios de salud en Argentina: reflexiones a partir del análisis de los resultados de dos encuestas nacionales.*
Ibel, Lagala, Yael Losardo, Moreno, Peñaloza Almaraz et al. *Por un niño sano en un mundo mejor. Sociedad Argentina de Pediatría.*
Lopez. *Hipertension arterial. RevPediátr Aten Primaria* vol.12 no.45
Menéndez Tuñón, A. Sariego Jamardo, E. Fernández Tejada, N. Fernández
García, P. López Vilar, A. Meana. *Consultas dermatológicas en Pediatría de Atención Primaria.*
PROSANE. *La importancia de la promoción a la salud dentro de las escuelas de educación básica. Septiembre 2007.*
Reichenbach JA. *Pediatría en Red. Vol 2. Primera edición. La Plata, Buenos Aires, 2017. p. 447-450. Evaluación oftalmológica en la infancia.*

Expertos consultados:

Dr. Juan Reichenbach

Dr. Héctor Trebucq

Médico, egresado de la UNLP, Médico Generalista y especialista en Terapia Intensiva, ex Director Asociado del Hospital Dr Héctor Cura de Olavarría, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Profesor Adjunto de Metodología de la Investigación en la misma Facultad.

Dr. Carlos Prego

Médico, UNLP 1986. Especialista Jerarquizado en Clínica Médica, UNLP - Colegio de Médicos de la Pcia de Buenos Aires. Profesor Adjunto ordinario, espacio curricular Salud del Adulto Clínico - Quirúrgica, Facultad de Ciencias de la Salud, UNCPBA. Vice Decano, 2016 - 2020.

Lic. Maria Laura Catalano

Nutricionista -Dietista, UBA. Jefa del Servicio de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría. Docente de Nutrición Clínica, carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud- UNICEN.

Dra. Rosana Gabriela Della Maggiora

Médica UBA 1998 Especialista Jerarquizado en Pediatría. Jefe de Trabajos Prácticos Salud Infanto Juvenil 2015-2020 Facultad de Ciencias de la Salud UNICEN. CO Directora de Región Pampeana Sur, Soc. Argentina de Pediatría 2017-2019. Jefa de Internación Servicio de Pediatría Hospital Cura 2018 -2020.

Dra. María Esther Gatella

Especialista en Medicina General Integral. Directora de Atención Primaria de la Salud de Olavarría desde 2015 a-2020. Coordinadora de la Residencia de Medicina General de Olavarría desde 1988 -2019. Ministerio de Salud de la prov.de Bs As. Jefa de Trabajos Prácticos de Salud Infanto Juvenil 2010 -2020 actualmente.

Dr. Gastón Seambelar

Médico, UBA, especialista en Pediatría Ministerio de Salud de la Nación y Colegio de Médicos Pcia BS As. Ex Jefe Residentes de Pediatría, ex Ayudante de Pediatría UBA, Ayudante de Salud Infantojuvenil Facultad de Ciencias de la Salud UNCPBA.

Ing. Daniela Pena

Ingeniera, UNCPBA 1987. Especialista en Gestión Universitaria, UNMDP 2009. Técnico Profesional UNCPBA 1993-2007; Secretaria de Gestión Facultad de Ciencias de la Salud 2007 hasta la actualidad.

UNA MIRADA A LA APS DESDE EL HOSPITAL. HOSPITALIZACIONES POTENCIALMENTE EVITABLES EN PEDIATRÍA



DR. JAVIER IGNACIO CABANA*

“...Estamos en una situación afortunada, aunque dolorosa de tener a nuestra disposición más actividades beneficiosas de las que podemos financiar... la decisión explícita de asignar recursos a un paciente es inevitablemente una decisión implícita de negárselos a otro paciente”.
Alan Williams, 1988

“El éxito de las acciones de salud pública es su invisibilidad...”
Varios autores, *Blog Economía y salud, AES, 2020*

Sumario

La Atención Primaria de la Salud es la estrategia sanitaria que demostró ser la más adecuada para el manejo de la mayoría de las patologías prevalentes en una comunidad. Permite, con un enfoque poblacional y territorial, adecuar los recursos a las necesidades sanitarias y epidemiológicas reales de cada región generando claros beneficios en la salud desde un enfoque preventivo.

Sin embargo, existen multiplicidad de ejemplos en los que la atención primaria de la salud no puede cumplir con su objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población. Las causas también son múltiples y variadas, incluso particulares de cada modelo de atención primaria frustran. Las barreras de acceso a la población, programas centrales que saltean la atención

primaria en el manejo de patología no transmisible, falta de incentivos para la aplicación adecuada de las estrategias de atención primaria, son ejemplos cotidianos de condicionantes para esta estrategia.

Introducción.

Una forma de medir la calidad de atención y capacidad de resolución en la atención primaria de la salud son las Hospitalizaciones Potencialmente Evitables por Condiciones Sensibles al Cuidado Ambulatorio que son aquellas en que una adecuada atención primaria de la salud permite su control en forma ambulatoria, sin necesidad de internarse. Se considera a las hospitalizaciones por dichas condiciones como un buen indicador para evaluar la capacidad de resolución y cobertura de atención primaria de la salud y las tasas elevadas de dichas hospitalizaciones son indicativas de una atención primaria subóptima.

Para poner un ejemplo podemos nombrar a la diabetes como condición sensible al cuidado ambulatorio. Si existe un adecuado control metabólico y nutricional, con acceso adecuado a la medicación e intervenciones de educación/concientización familiar en el ámbito de la atención primaria el porcentaje de diabéticos pediátricos conocidos que deban internarse por complicaciones de su enfermedad es muy bajo. Simplificando: si el diabético está bien controlado a nivel ambulatorio no debería tener complicaciones y por lo tanto no ingresa a internación

hospitalaria.

Es importante hacer una aclaración importante, el análisis de las hospitalizaciones potencialmente evitables no cuestiona la hospitalización en sí. No cuestiona si el diabético con una descompensación está bien o mal internado, ni tampoco evalúa casos individuales. Solamente analiza la existencia de internaciones asociadas a esta condición en particular y plantea que la existencia de un porcentaje elevado implica un manejo subóptimo en el ámbito ambulatorio. Esto permite tomar decisiones y mejorar la calidad de atención en la atención primaria.

Son múltiples las condiciones que cumplen con los criterios necesarios para ser consideradas sensibles al cuidado ambulatorio y es una decisión estratégica de cada sistema de salud cuales son sobre las que va a enfocar la evaluación. Dependerá de factores epidemiológicos y poblacionales particulares de cada región y de la planificación estratégica de los encargados de la gestión en dicha región.

A pesar de esto, existe relativo consenso a nivel global sobre las condiciones sensibles al adecuado cuidado ambulatorio adecuadas para valorar la atención primaria en Pediatría (tabla 1) y la mayoría de los estudios pediátricos toman a este grupo como el núcleo desde donde parte su evaluación.

De esta manera, al existir un núcleo de condiciones sensibles al cuidado de la salud que es tomado en casi todas las evaluaciones existentes podemos comparar las realidades de distin-

tas regiones y distintos sistemas en cuanto a su atención primaria (tabla 2), en los que podemos observar que la tasa de ocupación hospitalaria debida a hospitalizaciones potencialmente evitables es variable, lo mismo que las condiciones que llevaron a dichas hospitalizaciones. Pero que si se considera en cuanto a tasa por 1000 habitantes en edad pediátrica podemos ver que las hospitalizaciones potencialmente evitables son comparables en las distintas regiones.

No existen muchas evaluaciones sobre hospitalizaciones potencialmente evitables de Pedia-

Condiciones sensibles al adecuado cuidado ambulatorio
Infecciones de la vía aérea superior
Convulsiones
Diabetes
Tuberculosis
Infección del tracto urinario
Enfermedades Prevenibles por vacunas
Enfermedad Inflamatoria Pélvica
Déficit Nutricional
Gastroenteritis aguda y deshidratación asociada a gastroenteritis
Por enfermedades odontológicas
Asma
Neumonía
Anemia ferropénica
Infecciones de piel y partes blandas

Tabla 1- Condiciones sensibles al adecuado cuidado ambulatorio

Autor	País	Porcentaje de ocupación por HPE	Tasa /1000	ASCS más importante
Sam Lu, et al	USA	33%		Asma, Neumonía, Convulsiones
Casanova Matutano, et al	España (Valencia)	21%	9	Gastroenteritis, Infecciones Vía aérea superior, Neumonía
Casanova Matutano, et al	España (Cataluña)	15%	10	Neumonía, Gastroenteritis, ASMA
Jackson et al	Nueva Zelandia	32%	6,4	Asma, Neumonía, Gastroenteritis
Parker	USA	37%	10,9	Asma, Gastroenteritis, Neumonía

Tabla 2- Cuadro comparativo. Porcentajes de ocupación hospitalaria por Hospitalizaciones potencialmente evitables, tasa por 1000 habitantes pediátricos y condiciones asociadas al cuidado ambulatorio que más frecuentemente llevan a hospitalizaciones potencialmente evitables.

tría en nuestro medio. Un análisis retrospectivo realizado en la ciudad de Mar del Plata para el periodo 2014-2017 en el que se tomaron solo aquellos ingresos de menores de 15 años oriundos del partido de Gral. Pueyrredón en los que el motivo de internación fuera alguna de estas condiciones, nos muestra valores de ocupación hospitalaria por hospitalizaciones potencialmente evitables de 18 % con una tasa por 1000 habitantes menores de 15 años de 8,92 para el partido de general Pueyrredón. Siendo las causas más frecuentes de hospitalizaciones potencialmente evitables las convulsiones, Infecciones de piel, Gastroenteritis y Asma que implican más del 75% de los días de ocupación hospitalaria por hospitalizaciones potencialmente evitables en el Hospital Tetamanti de Mar del Plata para dicho periodo. (tabla 3)

Si se pudiera enfocar en estas 4 condiciones de salud asociadas al cuidado ambulatorio y diagnosticar cuales son los déficits que existen para su manejo adecuado en la atención ambulatoria podríamos reducir las hospitalizaciones asociadas a las mismas con impacto claro en la salud pediátrica de la región. Permitiendo una adecuada gestión de los recursos existentes orien-

tados al acceso equitativo y universal a la salud.

La evaluación realizada en el partido de Gral Pueyrredón muestra que las Hospitalizaciones potencialmente evitables permiten además el control de costos y disminución de la presión asistencial sobre el segundo y tercer nivel de atención.

El costo estimado global por Hospitalizaciones potencialmente evitables para el periodo analizado fue de AR\$ 54.419.039, que ajustados a cambio oficial de cada uno de esos años se traducen en U\$S 2.944.754. Esta cifra es más que significativa si se piensa que es un análisis centrado en población menor de 15 años de un solo distrito. Seguramente que las estrategias necesarias para mejorar la atención primaria en dicho distrito son mucho menos costosas si solo de inversión monetaria se tratara.

Jugando un poco con los números podemos tres pequeños escenarios hipotéticos (y aclarando que esta es una evaluación superficial con objetivo de dar contexto a estos valores y exponer la importancia de utilizar las Hospitalizaciones potencialmente evitables como monitoreo de la atención primaria para adecuar la inversión en Salud).

	2014	2015	2016	2017	Total
Convulsiones	1412	1600	1576	1608	6196
Infecciones de piel	706	975	839	1143	3663
Gastroenteritis	707	707	498	495	2407
Asma	91	385	564	582	1622
Prevenibles por vacunas	250	356	389	292	1287
Infecciones de vía aérea superior	231	175	325	405	1136
Infección de tracto urinario	255	241	187	317	1000
Neumonía	26	241	226	76	569
Déficit Nutricional	1	31	308	211	551
Procesos Odontológicos	26	60	96	124	306
Diabetes	15	73	74	94	256
Tuberculosis	0	62	3	4	69
Anemia por déficit	0	8	3	46	57
Enf. inflamatoria pélvica	0	8	13	3	24

Tabla 3- Tabla comparativa por días anuales de ocupación hospitalaria por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio para el periodo 2014-2017 en Hospital Tetamanti, Mar del Plata

Patología	Costo estadía total en AR\$	Porcentaje del costo total	Agregado de porcentaje (Relación de Pareto)
Convulsiones	13 334 653	24,50	24,50
Infecciones de piel	13 320 030	24,47	48,98
Asma	6 567 932	12,06	61,04
Gastroenteritis	5 311 483	9,76	70,81
Infección de tracto urinario	5 145 387	9,45	80,26
Prevenibles por vacunas	3 360 250	6,17	86,43
Neumonía	2 864 427	5,26	91,70
Infecciones de vía aérea superior	2 152 038	3,95	95,65
Déficit Nutricional	1 043 814	1,92	97,57
Procesos Odontológicos	579 686	1,06	98,64
Diabetes	484 966	0,89	99,53
Tuberculosis	130 713	0,24	99,77
Anemia por déficit	107 980	0,19	99,97
Enf inflamatoria pélvica	15 676	0,028	100
Total costos relacionados a HPE	54 419 039		

Tabla 4- Costo en AR\$ por patología para todo el periodo 2014-2017 y su impacto en el porcentaje total. Esto muestra cómo el enfoque en la adecuada atención en atención primaria de salud de solo 5 patologías permitiría reducir hasta en un 80 % el costo asociado a HPE.

En un primer escenario ¹ podemos plantearnos que medicamentos son necesarios para cada una de las 5 patologías que impactan en un 80% del costo asociado a hospitalizaciones potencialmente evitables y repartir de acuerdo a su impacto porcentual en la adquisición de dichos medicamentos. Ajustando el gasto realizado en dólares al cambio oficial actual² para permitir, más allá de las distorsiones existentes, una comparación en contexto de una economía inflacionaria y con un fuerte aumento de medicamentos durante el año 2019. Así podríamos distribuirlos en la siguiente tabla:

Patología	Porcentaje	Medicamento (valor de unidad)	Cantidad de envases/unidades
Convulsiones	24,50	Fenitoína jarabe 25mg/ml (AR\$470)	26095
Infecciones de piel	24,47	Cefalexina jarabe 500mg/5ml 90 ml (AR\$208)	58893
Asma	12,06	Budesonide 200 mcg con aerocámara (AR\$ 761)	7933
Gastroenteritis	9,76	Salas Rehidratación Oral por unidad (AR\$ 46)	106215
Infección Urinaria	9,45	Cefalexina jarabe 500mg/5ml 90 ml (AR\$208)	22744
Resto	20	Para el resto de las patologías	

¹ El primer escenario toma como precios de referencia de los medicamentos los que figuran en las últimas adquisiciones por parte del Min de Salud de la Pcia de Buenos Aires en el año 2020. Por otro lado, el autor entiende que en ciertas ocasiones y lugares los fármacos aquí propuestos pueden no ser los de primera elección. De nuevo vale la aclaración de ser este un ejemplo con un análisis superficial a fin de demostrar la importancia de la evaluación de las HPE.

² 1U\$=68 AR\$

Y esto sería solo para el partido de general Pueyrredón.

El segundo escenario³ a plantear es si se invierte ese dinero en agentes de Salud. La Municipalidad de General Pueyrredón cuenta con aproximadamente 80 pediatras trabajando en sus CAPS y centro de segundo nivel. Si el costo de las Hospitalizaciones potencialmente evitables se utilizara en su totalidad para el pago de los haberes de dichos agentes se podría pagar el sueldo de 47 pediatras es decir el 59% del plantel actual.

Por último, un tercer escenario⁴, sería generar una serie de estímulos económicos (pago por performance) basados en resultados y seguimiento de las 5 patologías más importantes en este estudio. En ese estudio de resultados no puede faltar la medición de las hospitalizaciones Potencialmente evitables de cada una de estas patologías. Con el dinero gastado se podría generar incentivos que puedan aumentar el ingreso de los agentes en hasta un 60% mensual, solo por hacer un buen control y seguimiento de los pacientes con estas patologías en el área de su CAPS.

De esta manera podemos ver que la evaluación de Hospitalizaciones potencialmente evitables por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio son una herramienta sencilla para monitorear la atención primaria de la salud y adecuar los recursos y esfuerzos sanitarios en su adecuada atención. Permitiendo la generación de programas, ofrecer incentivos y reducir barreras de acceso al sistema de salud. Entendiendo que no es necesario enfocarse en todas las condiciones sensibles al cuidado ambulatorio ya que la mayoría de las veces son 4 o 5 condiciones las que significan más del 75% de las Hospitalizaciones Potencialmente Evitables (relación de Pareto). Conociendo este dato en una comunidad, y reorientando los recursos a su manejo en la atención primaria, se puede lograr una distribución más equitativa de los mismos con impacto fuerte sobre la salud infantil.

3 Para el segundo escenario se plantea que un agente sanitario tiene en promedio un costo mensual de U\$S1200 que incluye sueldos, aportes y cargas sociales en General Pueyrredón. Y se calcula con 13 salarios anuales por el SAC.

4 Utiliza las mismas referencias que el escenario 2. Un sistema de pago por performance en este caso necesita muchísimas variables a implementar, no es sencillo y necesita nominalización, historia clínica única y otros elementos que implican una inversión en sí mismo. Volvemos a la aclaración de que estos escenarios sirvan para poner en contexto sobre el valor de estos montos,

Bibliografía

- Busby, J., Purdy, S., & Hollingworth, W. (2015). A systematic review of the magnitude and cause of geographic variation in unplanned hospital admission rates and length of stay for ambulatory care sensitive conditions. *BMC Health Services Research*, 15, 324.
- Cabana, J. I. (2018). Evaluación de Hospitalizaciones Potencialmente Evitables y sus costos asociados en la población pediátrica de un Hospital Especializado Materno Infantil para el periodo 2014-2017. Trabajo Final Intergrador Carrera de Especialista en gestión y economía de la Salud, ISalud.
- Caminal Homar, J. (2007). Las Hospitalizaciones por Ambulatory Care Sensitive Conditions y los resultados de la Atención Primaria. *Atención Primaria*, 39(10), 532-534.
- Caminal, J., Mundet, X., Ponsa, J. A., Sanchez, E., & Casanova, C. (2001). Las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions: seleccion del listado de codigos validos para España. *Gaceta Sanitaria*, 15(2), 128-141.
- Casanova Matutano, C., Peiró Pérez, R., Barba Albós, G., Salvador Vialta, X., Colomer Revuelta, J., & Torregrosa Bertet, M. (1998). Hospitalización pediátrica evitable en la Comunidad Valenciana y Cataluña. *Gaceta Sanitaria*, 12, 160-168.
- Jackson, G., & Tobias, M. (2001). Potentially avoidable hospitalizations in New Zealand. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 25(3), 212-221.
- Lu, S., & Kuo, D. Z. (2012). Hospital Charges of Potentially Preventable Pediatric Hospitalizations. *Academic Pediatrics*, 12(5), 436-444.
- Parker, J., & Schoendorf, K. (2000). Variation in Hospital Discharges for Ambulatory Care-Sensitive Conditions Among Children. *Pediatrics*, 106(suppl 4), 942-948.
- Pezzin, L., Bogner, H., Kurichi, J., Kwong, P., Streim, J., Dawei, X., Hennessy, S. (2018). Preventable hospitalizations, barriers to care, and disability. *Medicine*, 97(19), 1-8.

*Dr. Javier Ignacio Cabana

Especialista en Pediatría.

Especialista en Economía de la salud.

Jefe de trabajos prácticos. SaNNA. Escuela de Ciencias de la Salud. UNdMDP.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD DE MEDICINA



DR. FRANCO ARZAMENDIA*

DRA. ALINA GUARINO**

DRA. ANA MARÍA SEPULVEDA***

Sumario

La innovación curricular como un proceso creativo individual y colectivo que tiene que ver con desafíos pedagógicos e ideas transformadoras adaptadas a los cambios del mundo actual, y no como una cantidad de instrumentos o productos nuevos para adaptar las ideas tradicionales de la educación. En ese sentido, hablamos de actividades innovadoras en tanto entendemos, que lo “innovador” no son los recursos sino las ideas y los objetivos pedagógicos que aprovechan las múltiples opciones de las nuevas estrategias, entendidas como un sistema de herramientas implementadas de manera integral.

***...Amigos del alma
de mirada de cristal
y de sonrisas, siempre.
Con almas y de a muchos,
Solo así se aprende...
Juan Reichenbach.***

Desde el comienzo de la humanidad los contextos fueron determinando las bases de las relaciones sociales ¿relaciones humanas? ¿Relaciones de poder? ¿Relaciones equitativas? Constituyendo los pilares de las organizaciones de la sociedad. El estudio de la vida, de la salud, la medicina no escapaba a todos esos procesos generales. El estudio de la medicina era solamente una virtud de unos pocos eruditos, dueños del saber pertenecientes a las clases dominantes.

En esos tiempos el conocimiento de las ciencias médicas estaba circunscripto a un sector privilegiado y cerrado, con fuerte impronta del maestro y su alumno. Con el correr de los siglos se vislumbraba avanzadas culturas con prácticas de las ciencias médicas, basadas en sus investigaciones, adelantos económicos y políticos. Muchos de los cuales fueron borradas de la historia como las medicinas de los pueblos originarios por el avance de los sectores dominantes del planeta para ese momento histórico.

A principios del siglo XX, surge un nuevo sistema educativo para la carrera de medicina: el “Modelo Flexneriano” (Abraham Flexner, 1910) definía al estudio de las ciencias médicas en dos etapas bien diferenciadas, la primera relacionado a las ciencias básicas y la otra relacionadas al estudio y afianzamientos de habilidades y métodos clínicos de las ciencias médicas, es decir que luego de varios años, aparecía la práctica en un hospital al lado de la cama del paciente, considerando la única forma de aprender esta ciencia.

Este modelo, vigente en Programa de estudio de múltiples Facultades de medicina latinoamericanas contemporáneas, centra su formación netamente desde la visión biológica de la enfermedad dejando de lado la integralidad de la persona como ser biopsicosocial y su complejidad en su contexto histórico-social.

A mediados de los años sesenta surge un nuevo enfoque de estudiar las ciencias médicas

representando un paradigma antagónico al modelo “flexneriano” denominado Modelo “Crítico” que rompe con una mirada puramente hospitalaria y considera a la medicina que accede a la comunidad y al estudiante como “protagonista” del proceso de aprendizaje. Este modelo se basa en problemas, situaciones, casos o presentaciones, con fuerte base científica, con pensamiento crítico, manejo de información, adecuada comunicación y trabajo en equipo, con asistencia a la comunidad desde los primeros años de formación.

El modelo crítico comprende otros modelos curriculares como el integrado, el basado en problemas o presentaciones, complementa la teoría con la práctica, con varios escenarios que combinan desde una clase convencional a grupos más pequeños en aulas de aprendizaje basado en problemas o casos a laboratorios de habilidades clínicas, simulación, prácticas en terreno desde la atención primaria a la secundaria y terciaria. Desde el comienzo de las carreras los estudiantes se contextualizan con la realidad, permitiéndoles la inserción profesional en el campo mismo de las prácticas ya sea el trabajo comunitario de la atención primaria o en la atención secundaria en los hospitales. Aprendiendo no solo la enfermedad si no formándolos para la cuidar la salud.

Pero en la Educación de las carreras de medicina ¿cómo se lleva desde el modelo flexneriano al modelo crítico o al modelo integrado? ¿Será el Constructivismo en la educación quien nos brinde respuestas para mejorar esta educación de grado? Parece algo imposible, difícil para las carreras universitarias

Los invitamos a recorrer juntos apenas algunas reflexiones.

Desde principios de los años noventa comenzó a ampliarse la base teórica del constructivismo, la búsqueda de solución a los problemas en educación comienza en los procesos de transformación educativa. Los enfoques cognitivos o la adquisición del conocimiento que habían tenido un desarrollo muy intenso desde los años sesenta, los aportes socioculturales además de otras posiciones comenzaron a ser también referentes importantes en el intento de construir perspectivas teóricas y aplicadas para alcanzar una escuela que rompiera con el modelo tradicional y resultará más significativa.

El constructivismo ha realizado aportes muy importantes a procesos de cambio en la educación de numerosas sociedades, algunos de ellos han estado vinculados a transformaciones educativas sobre todo a procesos didácticos y psicológicos que componen al currículo propiamente dicho (sabiendo que el currículo contiene todo lo que debe de aprender un estudiante, el cómo y de qué manera lo aprenderá). Sin embargo, esto suelen implicar numerosas relaciones con políticas educativas es decir que remiten a problemas de tipo político y no exceden el ámbito de las didácticas que también son políticas. En este sentido lo que hoy se denomina constructivismo no es una corriente acabada sino más bien se trata de perspectiva abierta, que si bien tiene en su seno propuestas bien establecidas, comprende dudas debates críticas y autocrítica. Según Mario Carretero el constructivismo: *“básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo; tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos; no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano.”*1997.

Para el constructivismo existen 3 visiones sobre la construcción del conocimiento:

1) El aprendizaje como proceso individual, en la medida de Piaget, Ausubel y la psicología cognitiva se basa en la idea que el individuo aprende al margen de su contexto social.

2) El aprendizaje como interacción entre el sujeto y el contexto social: la interacción social favorece el aprendizaje mediante la creación de conflictos cognitivos que causan cambio conceptual. Es decir el intercambio de información entre compañeros que tiene diferentes niveles de conocimiento provoca modificaciones de los esquemas de los individuos y acaba produciendo aprendizaje basado en teorías vigotskianas, piagetianas y cognitivas.

3) Aprendizaje como resultado del contexto social: según la visión radical vigotskiana mantiene que el conocimiento no es un producto individual sino social. (Por lo tanto cuando el alumno realiza también una actividad individual el énfasis debe ponerse el intercambio social).

Estas currículas de modelos críticos e integrados proponen la construcción de conocimientos más que transmisión de saberes. Estos modelos integran el Constructivismo y la Educación.

Se hace necesario introducirnos en estos conceptos.

Motivación

Autores como Huertas, (2006) y Pintrich, (2006) consideran que en el proceso de construcción del conocimiento es fundamental comenzar mencionando la motivación, concepto que tiene relación directa en función de los objetivos que se proponen los estudiantes al elegir una carrera universitaria.

Partiendo de una idea general y considerando que las personas que deciden estudiar ciencias médicas lo hacen por un hecho generalmente especial en sus vidas, el cual puede ser positivo o negativo, parece suficiente esta experiencia para mantener firme esa motivación en el proceso de aprendizaje de esta carrera.

Sin embargo, entrando en el mundo de la motivación aparece la importancia del significado asignado para que se consigan estos objetivos, muchas veces sustentado por una situación muy negativa en la vida, y con buen desarrollo del concepto de resiliencia, o significado, basado en un estatus social o de prestigio familiar. Parece fácil la motivación durante todo el camino de aprendizaje de esta ciencia en particular, sin embargo, en la medida que se empieza a conocer y descubrir ese mundo anhelado, que muchas veces no tiene ninguna relación con lo imaginado, aparece la necesidad de redefinir ese proceso motivacional en estos estudiantes, momento en que se realizan planteamientos de incógnitas relacionadas a su pasado más cercano y ese futuro que cada vez parece más distante. Surge entonces, una crítica cada vez más compleja, la autoestima, el cual comienza a tomar un papel principal en la motivación y es el motor del sacrificio e interés en realizar cada paso de la mejor manera posible y así poder mantener firme esa idea inicial de superación a construcción del conocimiento en una rama de la ciencia con compromiso humanitario.

En base a las "Pautas de acción docente con repercusiones motivacionales de Alonso Tapia (1997). Teniendo en cuenta este modelo se citan determinadas pautas para tener en cuenta

al iniciar los encuentros con estudiantes:

- Presentar la información nueva o sorprendente, nombrar situaciones que ilustren el tema presentado en base a experiencias de alumnos y docentes y conociendo de esta forma los conocimientos previos.

- Para mantener el interés: Distribución de roles en los trabajos de grupos, usar imágenes, videos, narraciones o experiencias médicas, establecer metas parciales (definir metodología de trabajo en grupo, roles, puesta en común, análisis, y posterior exposición).

- Para transmitir aceptación: Permitir intervención espontánea de los estudiantes, escuchar activamente, pidiendo aclaraciones si se considera, hacer eco de las respuestas, asentir con la cabeza mientras el alumno o alumna hablan, señalar lo positivo de la respuesta, aunque sean incompletas, pedir razones de las respuestas incorrectas, no comparar a los alumnos, dedicar tiempo al alumno o alumna que demande ayuda.

- Para que los alumnos se impliquen de forma autónoma en el aprendizaje: explicar la significatividad de las actividades, dar oportunidades de opción, subrayar el progreso y el papel activo del estudiante en el mismo, sugerir el establecimiento de metas propias, sugerir la división de tareas en pequeños pasos, señalar la importancia de pedir ayuda, Hacer que alumnas y alumnos se paren a sentir sus logros.

- Para facilitar la experiencia de aprendizaje: interacción profesor-alumno, orientar hacia el proceso más que al resultado, orientar hacia la búsqueda de medios de superar las dificultades, señalar los progresos específicos de los estudiantes, hacer que el alumno o alumna se pare a pensar sobre lo que ha aprendido.

- Para facilitar la experiencia de aprendizaje: Proponer tareas que impliquen cooperación, posibilitar contraste de puntos de vista, prestar atención al tamaño del grupo, prestar atención a las características de los alumnos, proporcionar un guión que incluyan objetivos y pautas básicas de organización.

Según Alonso Tapia y Sánchez Fernando (2005) debemos centrarnos en el proceso de aprendizaje, que también influye en la motivación y no únicamente en una evaluación cuantitativa aislada de los contenidos, por esta razón pensar en evaluación formativas grupales e individuales, a medida que vayan finalizando

algunos contenidos responde a gran parte de la motivación. Nunca olvidándonos de que no formamos sólo en contenidos meramente técnicos y científicos, sino que también formamos personas para la vida con valores que no serán evaluados cuantitativamente. Por último, es importante la toma de conciencia de los/ las estudiantes de sus propios conocimientos y de su procesos de aprendizaje, por ende guiarlos a la reflexión es una de los objetivos dentro de la enseñanza, de esa manera los hace partícipe y el centro de su aprendizaje. Generar espacios para la práctica reflexiva del proceso de enseñanza y aprendizaje es una de las partes de estos modelos integrados.

Conocimientos previos

“Las teorías constructivistas de la educación (Coll, 1990; Pozo, 1996) en especial la teoría de la asimilación de Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), han destacado siempre que el proceso de construcción del conocimiento suponía una reelaboración de lo que el alumno sabía por el hecho” de incorporar nueva información a su estructura cognitiva.”

Es importante los conocimientos previos de los/ las estudiantes, porque están vinculados fuertemente con el cambio conceptual, es decir debemos “partir” de lo que el/la estudiante sabe, para asegurar el cambio conceptual. En cada encuentro se interactúa con los saberes previos de los /las estudiantes de las clases anteriores, se abstrae lo aprendido y se continúa incorporando una nueva información. Esto les permite activar en su memoria los conocimientos relacionados con ella, establecer conexiones e interpretar la nueva información en función del conocimiento previo existente. Se utilizan preguntas disparadoras sobre lo visto anteriormente.

Una vez observado esos esquemas previos se debe desafiar esos significados y sentidos y provocar su modificación, que sea en la dirección esperada en la construcción de conocimiento con respecto a los objetivos académicos

En este sentido surgen dos actividades imprescindibles en esta construcción de aprendizaje significativo, por un lado poder tener contacto con las ideas previas de los estudiantes, apoyarse en los significados y sentidos que lo sustentan y de esta forma establecer desafíos

para modificar o fortalecer esos esquemas de la mejor manera posible, sin afectar el proceso motivacional.

Las zonas de desarrollo próximo

Para mencionar la interacción entre pares es importante citar en primer lugar al psicólogo soviético L. S. Vygotski que propuso el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) defendiendo la importancia de la relación e interacción con otras personas como origen de los procesos de aprendizajes y desarrollo humanos, es decir *“la ZDP se puede definir como el espacio, en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener individualmente”*.

Según Vygotski el aprendizaje empieza primero con pares y luego es individual. De esta manera se considera la importancia de la relación social o interpersonal, para que luego los estudiantes de forma individual profundicen estos nuevos conocimientos.

Es importante considerar que se intenta crear en las aulas múltiples ZDP, de acuerdo a los grupos, ordenados por casos clínicos ofrecidos, los cuales van a depender de los contenidos a desarrollar, las características de los participantes de los grupos, los objetivos solicitados, conocimientos previos, lectura del tema presentado antes de asistir al encuentro y manera de guiar el trabajo en equipo.

Por otro lado, los docentes deben considerar que la intervención en los diversos grupos formados no debe ser la misma preferentemente, puesto a que cada ZDP adquiere una impronta característica y los docentes deben actuar en consecuencia.

Otro de los aspectos fundamentales en la creación de diversas ZDP en el aula es la organización detallada de los encuentros, que tiene que ser presentado a los estudiantes, considerando que son universitarios y que históricamente se estudió ciencias médicas de otra manera, entonces este proceso de trabajo colaborativo, en grupos, discutiendo contenidos que en otras Facultades de medicina es “transmitida” por un docente dueño de una verdad casi absoluta, tiene que ser justificada y generar convencimiento que es imprescindible la interacción entre

pares para generar aprendizaje significativo y así constituir ese pensamiento complejo para futuros profesionales de la salud críticos de su práctica.

Surge de esta manera dos formas de llevar adelante estas clases, por un lado mantener el formato del docente que se para delante y expone sus conocimientos unidireccionalmente para un auditorio o aquel docente que expone una modalidad de trabajos grupales en base a casos presentados y que sean los mismos alumnos y alumnas los que encuentren los procesos de aprendizajes en relación a lo considerado como pedagógico, claramente que los extremos de estas didácticas no serán constructores de aprendizaje significativo. Se tiene que considerar los contenidos, y en base a estos exponer, puede ser con cierta complejidad, las normas de trabajos y la manera de poder desarrollar ese proceso de construcción del conocimiento para que estos estudiantes que, de acuerdo a características personales, puedan diversificar las posibles tareas, que a la vez puedan elegir, y así encontrar el camino en su formación, con participación de todos los alumnos y alumnas y no dejarlos a la suerte de que porque se crean ZDP todos generen aprendizaje significativo, de ahí la importancia de la planificación y guía activa de los docentes.

El profesor deja de ser el centro como única fuente de conocimiento. Tomando un rol mucho más difícil el de la motivación, el de brindar herramientas que lleve a sus estudiantes a la pregunta de la duda y no las respuestas de alguna situación concreta.

Las zonas de desarrollo próximo se desarrollan en las aulas en grupos heterogéneos pequeños en donde el profesor participa desde el andamiaje, siendo un facilitador del conocimiento. *“El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han interiorizado, estos procesos se convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño. (Vigotsky, 1988, p. 138-139).”*

Como ha señalado Rogoff, “participar” significa tanto “tomar parte” como “ser parte”. Con relación a esto, se trabaja las zonas de desarrollo próximo, y el andamiaje en todos los encuentros, con didácticas pedagógicas de trabajo

grupal. Se tiene en cuenta que el aprendizaje y el desarrollo del conflicto cognitivo, se produce cuando los/las estudiantes vivencien y sean parte de la situación compartida.

En efecto se pone en práctica el concepto de aprendizaje en equipos en donde las tareas no constituyen en hacer algo como equipo sino en aprender algo como equipo, de esta manera son responsables del aprendizaje de sus compañeros como del propio. Hablamos de trabajo colaborativo, muy diferente al trabajo cooperativo que conocemos de las formaciones antiguas. Se prepara a los estudiantes para la verdadera realidad el trabajo en equipo que realizará en su vida como personal de salud, así como para el trabajo en red. Tan difícil construir una vez que llevamos en años en una formación individualista de la medicina, después nos lleva años en conquistar algo que podríamos tener desde el inicio de la formación.

Cambio conceptual y significativo

Para lograr un cambio conceptual como lo mencionan algunos autores como Rodríguez Moneo y J. Aparicio (1999), se debe enfocar sobre los distintos tipos de aprendizajes significativos, utilizando la diferenciación progresiva y la reorganización integrada de los conocimientos. Además en las diferentes materias a las que se denomina “unidades de aprendizajes”, se utiliza no solo una perspectiva puramente declarativa de los conocimientos, sino que además los conocimientos procedimentales que son el sustento de los declarativos. De esta manera, los docentes no sólo son transmisores de conocimientos sin sentido si no que en los escenarios de práctica se pone en juego el proceso de enseñanza- aprendizaje de los seminarios teóricos en donde los/las estudiantes adquieren dominios específicos en procedimientos enseñados.

Los contenidos del currículo se dividen en los distintos escenarios de aprendizaje, siempre conociendo los objetivos, ya que si no se pierden los propósitos y motivos. Por último y no menos importante se utiliza en el uso del conocimiento y la ilustración de ejemplos conocidos o cotidianos para conseguir cualquier cambio conceptual.

Construcción social del aprendizaje

“Una de las visiones del constructivismo es

el aprendizaje como resultado del contexto social...". "Esta propuesta por el psicólogo soviético L. S. Vygotski hace ya más de medio siglo en el marco de una posición teórica global que defiende la importancia de la relación y la interacción con otras personas como origen de los procesos de aprendizaje y desarrollo humanos. (Vygotski, 1979)."

Los médicos de esta carrera de medicina deben aprender los contenidos específicos desde la interacción social, de las prácticas culturales, de los procesos políticos, así como también los psicológicos y emocionales. Desde hace años el/la estudiante de medicina se dedica al estudio de la ciencia sin ningún contacto con la realidad recién hasta los finales de la carrera cuando realizan sus prácticas profesionales, por consiguiente la carrera con un modelo crítico acerca a los / las estudiantes desde el primer año y se los partícipe de los conflictos actuales. No podemos olvidar que es el ser social lo que determina la conciencia de los hombres

Además la interacción con la comunidad y su contexto social, les permite complementar todo lo aprendido en el aula, vivenciando en la práctica, y formando profesionales críticos de la realidad. Aprenderían a trabajar la empatía en la atención médica con actitudes humanitarias y éticas.

Para finalizar

Pensamos la innovación como un proceso creativo individual y colectivo que tiene que ver con desafíos pedagógicos e ideas transformadoras adaptadas a los cambios del mundo actual y no como una cantidad de instrumentos o productos nuevos para adaptar las ideas tradicionales de la educación. En ese sentido, hablamos de actividades innovadoras en tanto entendemos, que lo "innovador" no son los recursos sino las ideas y los objetivos pedagógicos que aprovechan las múltiples opciones de las nuevas estrategias entendidas como un sistema de herramientas implementadas de manera integral.

En la "innovación en la enseñanza", Marta Libedinsky retoma dos autores franceses: Cros

y Adamczewski (1996). Para diferencias el término de innovación de invención: *"Inventar implica crear algo nuevo en un dominio de conocimiento dado, mientras que innovar es otorgarles a esa creación un espacio social". "Este espacio social implica no sólo concentrarnos en las nuevas prácticas sino en cómo se implementan y en cómo piensan y actúan los actores involucrados en la educación"*

Bibliografía

- 1- Abraham Flexner, 1910)
- 2- M. Carretero .Constructivismo y Educación. 1997. Paidós. Buenos aires.México. Barcelona.1º ed. 2016.
- 3- J. Alonso Tapia. Motivación para el aprendizaje: La Perspectiva de los alumnos.(2005). Publicación: Ministerio de Educación y Ciencia (2005). La orientación escolar en centros educativos.Madrid: MEC. (págs. 209-242).
- 3-R. Baquero Orueta. Zona de desarrollo próximo, sujeto y situación. El problema de la unidades de análisis en psicología educativa . Zone of proximal development, subject and situation.The problem of units of analysis in educational psychology. Edición 2009. Vol 9. pp. 1-25 .
- 4-.Asensio, M., Asenjo, E. y Rodríguez-Moneo, M. De la discusión teórica de los tipos de aprendizaje informal y motivado, dos etiquetas distintas y un solo aprendizaje verdadero.(2012) En M. Asensio y E. Asenjo (Ed.) Lazos de Luz Azul: Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0. Colección Acción. Cultura, DIUOC, Barcelona. Capítulo 2.
- 5- R. Baquero. Vigotsky y El Aprendizaje Escolar .En Colección dirigida por Mario Carretero, Catedrático de Psicología Cognitiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Aique Grupo Editor S.A.LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA.Segunda edición: 1997
- 6- Rodríguez Moneo. Cambio conceptual y Educación. 2000 Revista Tarbiya nº 26. Edición ENTIMEMA Fuencarral, 70 -28004 Madrid.
- 7- César Coll; E. Martín; T. Mauri; M. Miras, J. Onrubia;I. Solé y A. Zabala. El constructivismo en el aula.1999 .Editorial Graó. Barcelona. Novena edición.
- 8- B. Rogoff. El desarrollo cognitivo y el contexto social. 1º Ed, Buenos aires.1993, Paidós.

*Dr. Franco Arzamendia

Pediatra. Prof adjunto de Tamizaje y Ciencias del diagnóstico. Escuela de Medicina. UNdMDP.

**Dra. Alina Guarino

Pediatra. Prof adjunta en Salud del niño, niña y adolescente. Escuela de Medicina. UNdMDP.

***Dra. Ana María Sepulveda

Pediatra. Prof adjunta en Salud del niño, niña y adolescente. Escuela de Medicina. UNdMDP.

SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, UNA MIRADA DESDE LA CURRÍCULA INNOVADA.



MARÍA FLORENCIA PAIARDINI
CINTIA ANABEL VALDEBENITO
CAMILA ROSANA VIGNONE

Alumnas de 4º Año de SaNNA de la Escuela de Medicina de la UNdMDP

DR. FRANCO ARZAMENDIA
DRA. ALINA GUARINO
DRA. ANA MARÍA SEPULVEDA

**Revisores*

Sumario

Una visión desde tres alumnas acerca de la enseñanza de la pediatría en la currícula innovada en la Escuela de Medicina de la UNdMDP. Los cambios de paradigma, la salud integral y la perspectiva de derecho y de género desde los testimonios de las estudiantes.

Cuando nos llegó la propuesta de contar qué significa Medicina y, más que nada, estudiar Salud del niño, niña y adolescente (SaNNA) bajo una currícula innovada, surgieron innumerables incógnitas, por ejemplo, ¿Qué es currícula?, ¿Qué es innovada?, etc. Las respuestas llegaron solas, basándonos en nuestra experiencia: un plan de estudios novedoso, interesante y que se abre a nuevas posibilidades. Destacando esta última palabra, posibilidades es lo que siempre nos otorga nuestra Carrera de Medicina. Pero ahora se despertó otro interrogante, teníamos que relatar nuestra propia experiencia.

¿Cómo es nuestra experiencia en la Escuela Superior de Medicina, bajo una currícula innovada?

Pregunta amplia y compleja de responder. Es inevitable, ante esta pregunta, rememorar un sinfín de situaciones y conocimientos, adquiridos a lo largo de nuestros años de estudio. Pero deberíamos comenzar por el principio, como toda historia, por el “Había una vez”. Igualmente, si hoy nos preguntasen ¿Por qué estudias Medicina?, sencillamente, quizás, en este preciso instante, diríamos “no lo sé”, pero nos miramos y sabemos que no nos veríamos haciendo otra cosa; estamos justo donde queremos estar.

Un mismo sueño, el mismo objetivo y la misma pasión, hoy nos reúnen en las aulas. Podríamos decir que todo empezó allá por el 2016, cuando los noticieros, radios y los diarios anunciaban la apertura de la Carrera de Medicina en Mar del Plata.

Los mensajes llegaban: “Es tu carrera, anotate”, “Dale que cumplís tu sueño”, “Medicina en Mar del Plata, es tu oportunidad”; amigos y familiares incentivaron el ingreso.

Así nació la Escuela Superior de Medicina, así nacieron los primeros estudiantes, la cohorte

2017, un grupo heterogéneo de desconocidos que, por alguna razón del destino, recorrían esas cuatro paredes y no sólo tenían en común el espacio físico sino que compartían ese tan famoso “Había una vez” de estudiar Medicina.

Las expectativas que se evidenciaban desde la perspectiva de los medios masivos de comunicación fueron superadas: una amplia demanda, con más de 2000 inscriptos y franjas etarias diversas, ya que muchos estudiantes esperaron por años la apertura de la misma, siendo ésta su única oportunidad de estudiar lo que siempre desearon.

Medicina llegó para quedarse, y para impactar en la sociedad, se presentó en el Partido de General Pueyrredón con una currícula distinta a la planteada en ciudades como La Plata o Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Currícula a la que titularon “innovada”. Como estudiantes, nuestra visión era distinta, ya que predominaban la ansiedad, la alegría y los nervios; por fin estábamos en donde siempre quisimos estar, por fin éramos “estudiantes de Medicina”.

Todavía nos acordamos de ese inicio de cursada; las primeras materias nos encontraron en verano, todavía era Febrero cuando tuvimos la primera clase de Aproximación a la Medicina, materia que, como su nombre lo indica, nos acercaba entender un poco qué pasa en el campo de la salud, en torno a la profesión médica. En ese momento, no éramos conscientes de que los temas planteados en esa materia nos acompañarían en toda la carrera e, incluso, luego en la práctica. Temas que desde ese comienzo dejaban entrever que algo había cambiado, abarcarse en los conceptos de Promoción de la Salud, Prevención Primaria, Secundaria, Terciaria e incluso Cuaternaria.

El foco estaba puesto en prevenir, evitar enfermar y mantener la salud de las poblaciones. Un mensaje que hoy, siendo estudiantes de cuarto año, tenemos grabado a fuego.

El Plan de Estudios también había cambiado; las materias típicas no existían, ¿o sí? Materias que articulaban distintas áreas, relacionando lo clínico con lo comunitario. Porque después de todo, somos entes complejos, con células, tejidos, órganos y sistemas que se relacionan entre sí para el funcionamiento coordinado, pero también somos entes sociales que viven en comunidad.

Entendiendo todo esto, ¿cómo sería posible estudiarlo por separado? Así, comenzamos a cursar Articulación Básico Clínico Comunitaria I, la “primera ARTI”, llamada así por los conocidos y docentes; cursadas que se teñían de Histología, Fisiología y Anatomía juntas, casos clínicos a modo de ejemplo y temas sociales, pero no menos importantes, como la comunicación de malas noticias.

Siempre recordamos una de las clases en donde todos los/as compañeros/as estábamos preocupados/as, resolviendo los cuestionarios y guías sobre tejido epitelial, pero el tema de ese día era justamente la transmisión de malas noticias. Entre nosotros, al ver el tema, lo tomamos con menor valor comparándolo con los demás tópicos que se abarcarían en esa materia.

El docente pidió silencio, al ver que no estábamos completamente enfocados, y nos dijo: “la primera vez que tuve que dar una mala noticia fue el primer día de mi residencia médica, se me murió un paciente en mi guardia, y cuando tuve que acercarme a la familia no sabía cómo hacerlo. Me di cuenta que, durante todo mi recorrido universitario, nadie me había dado las competencias para sobrellevar semejante situación”.

El silencio se hizo presente en el aula, comprendimos que todos los temas tenían la misma relevancia e incluso, a veces, más que los temas netamente anatómicos, entendimos que éramos privilegiados/as, estudiantes de primer año formándose en temas tan relevantes para ejercer una práctica que, durante muchos años, se olvidó que es humana. Hoy, la currícula intenta reflotar estos conceptos.

La currícula innovada, a su vez, se define por la inclusión de distintas unidades de aprendizaje basadas en la vinculación del proceso Salud-Enfermedad con cuestiones sociales, culturales, económicas, etc. que exceden a la visión puramente biológica del proceso.

En nuestro caso, fueron éstas las que nos brindaron múltiples herramientas que se encuentran postergadas en la práctica médica actual. Navegamos y nos inundamos en muchísimos autores, recorrimos parte de la Historia de la Salud de nuestro país, base fundamental para comprender la actualidad de nuestro Sistema de Salud. También leímos sobre la importancia de la Salud Pública y Colectiva, pasando por la Interculturalidad, la Promoción y Prevención de la Salud, el trabajo en Red y las innumerables

esferas que componen al ser humano como un ente interdisciplinario, convirtiendo al médico/a en un actor más del proceso Salud-Enfermedad-Atención.

El contacto temprano con la comunidad, el paciente y con las instituciones médicas se hizo presente desde primer año con el escenario Campo. Un escenario que nos situaba en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) de los barrios periféricos, analizando no sólo la consulta médica, sino que, también pudimos adentrarnos para conocer los Determinantes Sociales de la Salud en primera persona.

El enfoque actual se centra en el proceso salud-enfermedad, en donde los factores socioeconómicos, culturales y políticos inciden de forma negativa o positiva en ese proceso. La visión dejó de estar centrada en lo biológico y en los microorganismos patógenos, las formas de enfermar y morir ya no eran las mismas, la sociedad cambia y la medicina debía cambiar para satisfacer las necesidades de las comunidades.

El escenario Campo nos acercó desde primer año a estas nuevas nociones: pudimos realizar informes sobre las comunidades, sus necesidades, áreas geográficas, características de sus viviendas, servicios vitales como el agua potable o saneamiento de cloacas.

Hoy, parándonos desde cuarto año, podemos magnificar lo importante que es el contexto, teniendo en cuenta que, después, la práctica muchas veces cae en la limitación de un consultorio, en donde la persona queda completamente abstraída de sus dimensiones, en donde se prima la presencia de enfermedad y se trata a la misma, olvidándonos de, quizás, la situación que lo aqueja actualmente.

El paso por los Laboratorios de Habilidades Clínicas. ¿Qué consideras una habilidad clínica? Quizás, la mayoría respondan lo típico, el uso de artefactos avanzados, como radiógrafos, ecógrafos, otoscopios, saturómetros, etc. o consultas con pacientes, entrevistas, examen físico exhaustivo y análisis complementarios.

Sin embargo, este laboratorio está equipado con maquetas y camillas, y es guiado por consignas de “juegos de roles”, en torno a situaciones clínicas cotidianas donde aprendimos, primero y principalmente, a ponernos en el lugar del paciente, a transmitir empatía, tranquilidad,

consejería, a ofrecer opciones y decisiones compartidas, competencias que muchas veces son olvidadas por los profesionales de la salud a la hora de la práctica médica, y que son vitales para el ejercicio de la profesión. También aprendimos semiología, practicamos maniobras; así como auscultación y toma de la tensión arterial, hicimos exámenes neurológicos y electrocardiogramas, herramientas que nos acompañarán a lo largo de toda nuestra carrera laboral.

De nuestro paso por la Escuela Superior de Medicina, no podemos dejar de mencionar los talleres de ABP -sigla para Aprendizaje Basado en Problemas-, escenario práctico-teórico en el cual se toma un caso clínico como eje central y el docente/tutor funciona de guía en el proceso, para luego llevar a cabo un trabajo colaborativo con diversos compañeros /as en un grupo reducido.

Es muy enriquecedor ser parte del proceso cognitivo que se genera en grupo, preparándonos para ese trabajo en equipo que tendremos como trabajadores de la salud. De este escenario, se destacan el estudio individual, grupal y la búsqueda bibliográfica de información adicional para poder resolver de la mejor manera la situación establecida con un abordaje interdisciplinario.

También debemos hablar de la Semana de Integración, dispositivo pedagógico cuya finalidad consiste en realizar planificaciones de proyectos de educación y Promoción de la Salud, en el marco de la carrera de Medicina.

Obviamente que, como estudiantes, no lo vivimos sólo así. Explicándolo en términos estudiantiles, la Semana de Integración es una semana completa, dentro del calendario académico, destinada a desarrollar un contenido que sea transversal a todos los años pero principalmente que relacionado con nuestra comunidad y sus necesidades, el cual se elige por diferentes mecanismos: prevalencia, incidencia, votaciones entre propuestas, etc.

Durante nuestros años de estudio, pudimos disfrutar de distintas temáticas: accidentes de tránsito, nutrición, lactancia materna e inmunidad, infecciones de transmisión sexual, donación de órganos y tejidos. Pero, no sólo participamos en el desarrollo de las mismas, sino que fuimos protagonistas.

Además de charlas, talleres, actividades y jue-

gos relacionados con el tema en cuestión y el análisis del mismo desde otro enfoque, intervenimos en la comunidad con acciones educativas, promo-preventivas con un compromiso de llegar desde la universidad y devolver lo aprendido.

Es imprescindible destacar el trabajo cotidiano de todos los docentes que día a día acompañan este proceso, esta experiencia de estudiar en una currícula innovada que, por su carácter novedoso, asusta, y porque es visionaria y plantea los cambios que la salud de hoy necesita.

Estos docentes que pasaron muchísimas noches armando clases, brindando ayuda y consejos constantemente a sus estudiantes, apoyándonos y creyendo en nosotros; con ellos, muchas veces nos encontramos compartiendo, además de clases, mates y comidas; esos docentes que nos tratan como personas y no como un número más en la lista de estudiantes. Porque uno también aprende y replica los ejemplos que recibe, uno también se forma de las acciones de quienes los precedieron.

El tema que nos reúne, no es solamente nuestro paso en general por la Escuela Superior de Medicina, pero no podíamos dejar de nombrar todo lo que la compone; innumerables espacios físicos llenos de vida, corazones que laten un mismo sentimiento, que esperan sentar precedentes, siendo los profesionales del Sistema de Salud del mañana.

Ahora sí. ¿Cómo se estudia a la Pediatría a través de esta currícula innovada? Si buscamos una definición en Internet, para calentar los motores, la Pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. Podríamos hacer un impasse antes de retomar con esta definición, y relatar nuestra propia experiencia.

En la Escuela Superior de Medicina, la salud del niño, niña y adolescente es el punto de mira, el eje del asunto y el principal objetivo a lograr.

Creemos firmemente en que, antes de patologizar cualquier circunstancia, es imprescindible conocer los hitos madurativos normales, los cambios fisiológicos, el crecimiento y sus componentes. Por eso, desde la Carrera de Medicina, en segundo año, se conoce al niño, niña y adolescente en la Unidad de Aprendizaje “Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo”. Como su nombre nos indica, descubrimos en ella todas las etapas por las que pasa un niño, una niña, desde que nace y durante todo su crecimiento, con las respecti-

vas evoluciones físicas, cognitivas, del lenguaje, sociales, etc. que se presentan en este período. La unidad de aprendizaje consta clases teórica y prácticas, además de prácticas en el escenario de Campo, en donde construimos las bases de la vivienda y las necesidades básicas que favorecen el buen crecimiento, Aprendizaje Basado en Problemas, con la guía de casos clínicos que involucran temáticas como parto respetado, ictericia neonatal, etc. y el Laboratorio de Habilidades Clínicas; en este último, pudimos analizar los pasos de la consulta, siempre teniendo los derechos del niño, niña y adolescente como guía, en conjunto con la perspectiva de género.

Pasaron los años y también los conocimientos, a cada minuto nos acercábamos y nos posicionábamos en escalones cada vez más altos.

El porcentaje de título médico/a del SIU Guaraní crecía, y en conjunto crecía, poco a poco, nuestra habilidad clínica.

En cuarto año, y de la mano de la virtualidad por la situación de pandemia debido al COVID-19, nos encontró Salud del Niño, Niña y Adolescente. Ésta era una de las asignaturas más esperadas; ya sabíamos todos los eslabones del desarrollo y las pautas de alarma correctas, y ahora se nos pedía que lo pongamos en práctica. Era turno de pararse en las enfermedades, de relacionar todas esas competencias aprendidas. Nuestras ansias eran demasiadas, pero nuestros docentes, como siempre, fueron guías y tutores, supieron calmar esa ansiedad y definir el rumbo, del cual supieron decir: *“El rumbo es la salud sobre la enfermedad, con la clínica integral como herramienta.”* Profesor titular de SaNNA. Dr Juan Alberto Reichenbach

Con SaNNA (Salud del Niño, Niña y Adolescente), la modalidad era distinta, las situaciones clínicas, tan esperadas, se hacían presentes, y era hora de resolverlas, pero no bastaba saber de Anatomía, Histología y Fisiología, no bastaba con saber la signo-sintomatología o el agente etiológico relacionado con la enfermedad; se hace presente algo más que un cuadro agudo, algo más que una patología normal de guardia o consultorio, se hace presente, también, una realidad.

¿Qué realidad? Una realidad que es más común de lo que a veces uno se imagina, que lamentablemente aqueja a muchos niños, niñas y ado-

lescentes, una realidad en donde se produce la abolición de los derechos, donde no hay perspectiva de género, donde existe el trabajo infantil, la desnutrición y persisten enfermedades fácilmente prevenibles, donde los niños, niñas y adolescentes no pueden jugar o no tiene acceso a las condiciones de vivienda o escolaridad adecuadas. Si esta realidad existe, ¿cómo podemos dejarla de lado en la consulta?

Por esta razón, está claro que, como futuras profesionales de la salud, es relevante saber de enfermedades, pero queremos destacar que la nueva visión no apunta solo a ese punto; los niños, niñas y adolescentes, al igual que los/las adultos, complejos con individualidades propias y sería contradictorio abstraerlos/as a un entorno sólo hospitalario en donde solamente visualizamos un cuadro agudo y lo tratamos en consecuencia. Para no caer en la mediocridad humana de una práctica milenaria, la currícula innovadora nos brinda desde el día uno, un sinfín de posibilidades ¿Se acuerdan las que nombramos al principio?

Para concluir, creemos estar listas para dar nuestra propia visión de esa tan vacía definición de “Salud del niño, niña y adolescente” con la que comenzamos párrafos atrás. Esa definición, sacada de diccionario, y que seguramente nos acompañaba a todos los/las estudiantes antes de abrir nuestra cabeza y corazón; porque de eso se trata esta rama de la medicina. Hoy, después de haber formado parte de las asignaturas de Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo y de Salud del Niño, Niña y Adolescente, podríamos gestar una definición propia de la práctica pediátrica, entendiéndola como una práctica que busca la SALUD INTEGRAL del niño, niña y adolescente, definiéndolos como sujetos de derechos, basándose en la perspectiva de género, con el fin último de la promoción, prevención y tratamiento de enfermedades.

***Revisores:**

Dr. Franco Arzamendia

Pediatra. Prof adjunto de Tamizaje y Ciencias del Diagnóstico. Escuela de Medicina. UNMDP.

Dra. Alina Guarino

Pediatra. Prof adjunta en Salud del niño, niña y adolescente. Escuela de Medicina. UMDP.

Dra. Ana María Sepulveda

Pediatra. Prof adjunta en Salud del niño, niña y adolescente. Escuela de Medicina. UMDP.

MIS LUCHAS POR LA SALUD COMUNITARIA



PROF. DR. HORACIO PRACILIO*

***“La salud surge de la lucha continua
del hombre frente a los conflictos
y a su solución”***

Floreal Ferrara

El ciclo de vida profesional es un largo proceso de desafíos y oportunidades, que no siempre sabemos o podemos volcarla en beneficio de la comunidad que nos facilita nuestro crecimiento personal. He tenido el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria en una Universidad Pública, gracias al esfuerzo de mis padres que se sacrificaron en momentos difíciles para mantener a tres hijos estudiando a más de seiscientos kilómetros de distancia. He tenido la suerte de ejercer la profesión médica que me fue entusiasmando gracias a las enseñanzas de mis maestros, y de ejercer la docencia de grado y posgrado durante más de 40 años, de una especialidad que me permitió descubrir y enseñar a miles de estudiantes y profesionales los nuevos paradigmas de la salud colectiva. También tuve el desafío y la oportunidad de trabajar durante más de tres décadas en la planificación de la salud pública, y asumir durante un período de cinco años la responsabilidad de un cargo político en la Provincia de Buenos Aires. Aun así, no sé si he llegado a pagar mi deuda con la sociedad. Pero puedo asegurar que, dentro de mis posibilidades, he tratado de saldar esa deuda luchando en distintos frentes por la salud colectiva, siempre en base a los principios éticos que aprendí de mi familia y de mis maestros.

A pedido del autor principal de este libro, asu-

mo otro desafío que significa tratar de resumir en pocas páginas algunas de las experiencias de este largo camino profesional, que contemplan éxitos y fracasos, pero siempre valiosas enseñanzas, por lo cual lo considero una nueva oportunidad de contribuir a este proceso de educación médica continua del que forma parte esta publicación. Para ello, me referiré brevemente a las tres principales experiencias de mi vida profesional: los aprendizajes de la formación y el ejercicio profesional, el desafío de haber contribuido a ciertos avances en la educación médica, y el orgullo de haber tenido la oportunidad de participar de una gestión política que considero una verdadera revolución democrática y sanitaria.

Una formación integral extracurricular

Todos los que hemos pasado por una Facultad de Medicina sabemos que la verdadera formación médica no se logra solamente con las clases, trabajos prácticos y exámenes en las Cátedras, ni tampoco con la mayor o menor lectura de libros o, en muchos casos, de apuntes. El aprendizaje de la medicina, y sobre todo del ejercicio profesional, se obtiene a través del currículo real de la formación médica, que es el conjunto de experiencias del estudiante a lo largo de su carrera, que surge no solo del cumplimiento de las obligaciones del Plan de Estudios, sino a través de las actividades curriculares y extracurriculares que realiza durante el período de formación, y que debe continuar a lo largo de toda su vida profesional.

En mi caso y de todos los estudiantes de medicina de mi generación en La Plata, durante la década del 60 y principios de los 70, que incluye la época de una Universidad protagonista de la “noche de los bastones largos”, la educación médica formal transcurrió en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Se trataba y sigue siendo un espacio académico con excelentes Profesores en todas las disciplinas básicas y clínicas, investigadores de prestigio nacional e internacional, pero impregnada del modelo biomédico con escasas materias y contenidos de contenido humanístico y social. Una de mis experiencias fue precisamente luchar frente a ese modelo médico hegemónico, dentro mismo de su mejor expresión académica.

Debo confesar que ingresé a la carrera de medicina a instancias de mi padre, sin estar muy seguro de mi vocación a esa profesión, ya que en mi paso por el Colegio Nacional de Santa Rosa (La Pampa), mi ciudad natal, siempre me habían interesado más las materias humanísticas, y las actividades culturales. A los 17 años, muy lejos de mi casa, tener como primera experiencia de la carrera ver y examinar un cadáver en un subsuelo frío y oscuro, con un insoponible olor a formol, me impactó fuertemente. No tengo duda que esa experiencia negativa, y luego otras a lo largo de toda la carrera, algunas negativas y otras positivas, me hicieron volver a mi original vocación humanística en la elección de la especialidad, de clínica médica primero, y de medicina sanitaria después.

A partir del cuarto año de la carrera tuve la suerte y la oportunidad de poder ingresar como practicante en la salas de clínica médica del Hospital General de Agudos “General San Martín”, de La Plata, donde desarrollé mi mayor experiencia extracurricular de mi formación médica, con el Maestro Prof. Dr. Bernardo Eliseo Manziño, y su discípulo predilecto, el Dr. Jorge Efraín Salvioli, en las Salas IV y II, a las que concurrí diariamente durante los cinco años finales de mi carrera, y otros cinco años más como médico concurrente. Al mismo tiempo, en esa época tuve el gran privilegio de conocer y asistir a las clases del Dr. Floreal Ferrara, Profesor Adjunto de la Cátedra de Higiene, Preventiva y Social, en el aula de Cardiología en el subsuelo del Pabe-

llón Rossi del Policlínico “San Martín”. A partir de esas clases, Ferrara fue mi primer maestro y promotor de mi vocación por la medicina sanitaria.

La experiencia en la sala del Hospital me permitió consolidar, recién allí, mi vocación médica al encontrarme con personas enfermas a quién cuidar, hablar y consolar, y poder colaborar y aprender con excelentes profesionales la dinámica asistencial de un gran Hospital. Pero también pude apreciar los aspectos negativos del modelo hospitalario muchas veces despersonalizado, centrado en la enfermedad y no en la salud ni en el enfermo, otras veces en la enseñanza por encima de la asistencia, fragmentado por especialidades y con una enorme ineficiencia funcional al realizar actividad médica solo cuatro a cinco horas por día de lunes a viernes, quedando el resto de los días y horas a cargo de la guardia y del personal de enfermería.



Una mala experiencia: *La mayor experiencia negativa de esa época en el Hospital fue un breve paso por la guardia, a la que todos los estudiantes de medicina aspiraban a entrar en algún momento, dada la permanente consigna que nos daban los médicos recibidos, que nadie podía ser buen médico si no hacía guardia de emergencia en un Hospital. Como en esa época vivía precisamente enfrente del Hospital San Martín, y un médico de la sala me invitó a sumarme, me decidí y entré un día tímidamente a la guardia del día sábado. Lo que viví en esas horas contrastó fuertemente con mi experiencia en la sala de Clínica Médica, tanto en el modelo de atención de las urgencias, como en la falta de respeto a normas éticas fundamentales. Desde una atención despersonalizada, a veces de maltrato al paciente que consulta a la guardia cuando se supone que podría haberlo hecho en el consultorio, de respuesta sólo al síntoma sin profundizar en la problemática total del paciente, en base a un examen clínico superficial limitado en el mejor de los casos a la parte afectada, hasta la irresponsabilidad de asignar a un estudiante la atención clínica de algún paciente y una práctica de cirugía menor sin ningún tipo de supervisión. Pero lo peor fue cuando ante una paciente joven con un síndrome de fosa*

ilíaca derecha, que yo había atendido y decidido internar, pero que su cuadro se inclinaba más a una adenitis mesentérica que a una apendicitis, dos practicantes o médicos jóvenes a los que consulté, los escuché decidir la operación “para hacerse la mano”...! Esta escena, que la recuerdo hasta hoy, colmó mi tolerancia ética y aunque creo no habían pasado más de seis horas desde mi ingreso, crucé la calle y no volví nunca más a la guardia. Muchos años más tarde, en esta misma guardia tuve otra experiencia negativa, esta vez como familiar, cuando siendo ya médico llevé de urgencia a mi suegra de 86 años con un ACV, fui atendido por practicantes que no sabían que hacer y me pedían que me fuera, y que finalmente murió en mis propias manos tratando de reanimarla, hasta que llegó el Jefe de Guardia que estaba durmiendo en el piso de arriba. Muchas veces quise creer que mi experiencia había sido rara o excepcional, pero a partir de mi posterior trabajo profesional y docente, investigando con médicos, estudiantes y pacientes, pude advertir que lamentablemente el modelo de atención de las guardias sigue siendo igual, o peor. Gran parte del problema reside en la increíble persistencia de la guardia de 24 horas, que hace mucho tiempo debió ser desterrada de nuestros hospitales, como se ha hecho en muchos lugares del mundo y establecimientos públicos y privados. En mi rol de sanitarista, en varias oportunidades intenté modificar la Ley de Carrera Hospitalaria para eliminar la guardia de 24 horas: en mi gestión en el Ministerio de Salud, como asesor en el Senado provincial y en la Comisión de Salud del Colegio de Médicos. En todos los casos, perdí la batalla, contra el sistema y contra la decisión de los propios médicos, que por distintas razones, principalmente económicas, se resisten o toleran esa verdadera aberración de la práctica médica. Lo único que he podido hacer es insistir desde la docencia, de pre y posgrado, en el gran riesgo para la calidad de la atención médica que significa que un médico atienda a un paciente luego de 22, 23 o 24 de no dormir, lo que ocurre frecuentemente en una guardia muy activa. Lo considero el mejor ejemplo de deshumanización de la medicina, tanto para el médico como para el paciente. Y también en mi actividad docente, he utilizado a la guardia como ejemplo contrario al modelo de atención integral, continuo y humanizado de la medicina general o familiar, de la

Pediatría o de la Clínica Médica, de la misma forma que Mohamed Yunus, creador del Banco de los Pobres (Grameen) dice en su libro que para crearlo tuvo que hacer exactamente lo opuesto a un Banco tradicional. Sin embargo, debo reconocer que luego tuve la oportunidad de realizar guardia en el Hospital “Horacio Cestino” de Ensenada, hasta recibirme, y la experiencia fue totalmente diferente, con médicos y practicantes de gran calidad humana, algunos fallecidos que me enseñaron mucho, y otros grandes amigos como Raúl Orellana, Hugo Alvarez, Aldo Lauhi-rat y Roberto Manuele, mi médico de cabecera.



Afortunadamente, mi ámbito principal de formación fue la sala de clínica médica, en la que tuve el privilegio de ser practicante y discípulo del Profesor Bernardo Manzino, donde pude apreciar los verdaderos valores de una medicina humanizada, gracias a sus enseñanzas al lado de la cama del enfermo. Manzino era discípulo del Profesor Luis Felipe Cieza Rodríguez, a quién tuve oportunidad de conocer en sus últimos años, y valorar su gran capacidad semiológica precisamente en un paciente bajo mi cuidado, diagnosticando una hemorragia pericárdica con la sola percusión del corazón. También tuve la suerte de compartir la actividad de la sala y de la Cátedra de Medicina Interna “A”, de la que era titular, con la mayor parte de sus principales discípulos, que eran docentes de la misma, como Jorge Efraín Salvioli, Oscar Giacomantone, Vicente Primerano, Domingo Negri, Rubén De Marco, Tamara Micyk, y otros clínicos destacados como Alberto Luchina, Alfredo Vitale y Mario Migliorero.



La ética médica del Maestro: Del Profesor Manzino tengo recuerdos imborrables de sus clases magistrales con pacientes, las que grabábamos y publicábamos junto con mis compañeros Jorge Colombo, Evaristo Rolón y Hugo Alvarez, cuyos originales donamos a la Cátedra al recibirnos. Sus frases más recordadas las repetí miles de veces posteriormente a mis alumnos de la Cátedra de Salud, Medicina y Sociedad durante más de 30 años: “Un paciente joven, pálido, que habla guaraní, es una ancylostomiasis hasta

que no se demuestre lo contrario”, mostrando la relación entre la clínica y la epidemiología con tres elementos orientadores del diagnóstico: edad, anemia, procedencia del litoral. - “Lo primero que debe hacer un médico al entrar a la casa de un enfermo, o en un paciente internado, es pedir una silla, para poder mirar sus ojos a la misma altura, y enseguida tomarle la mano para comprobar el pulso, pero sobre todo para tocar su piel. Podrán comprobar el mágico efecto tranquilizador que produce sobre el paciente”. “Cuando tengan una duda frente a un paciente, piensen que se trata de usted mismo o un familiar. Enseguida tendrán la respuesta”. Manzino no era creyente, pero última se parece mucho a aquella de Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña: “Haced a los demás lo que quisierais para ti”. Estas enseñanzas, de un valor ético universal que aprendí mucho antes de conocer la bioética, las apliqué durante los diez años que ejercí la clínica médica, y hasta hoy con mis familiares o amigos que me consultan por algún problema.



Mi otro gran maestro en el campo de la clínica médica fue el Dr. Jorge Efraín Salvioli, ya como médico concurrente en la Sala II del mismo Hospital, y participando en su novedosa propuesta del consultorio externo de la sala, donde nace el Primer Curso de Posgrado de Clínica Médica de la Facultad, convertido luego en Especialidad Universitaria. Pero sobre todo tuve el privilegio de ser su amigo y colaborador, en largas reuniones nocturnas en la biblioteca de su casa, ayudándolo en la redacción de algunos de sus libros sobre hepatología y diabetes, al que contribuí con un capítulo sobre epidemiología de la diabetes. Como un verdadero maestro, le gustaba sugerir a cada uno de sus discípulos que se fuera preparando en alguna sub-especialidad de la clínica médica, a cada uno según su preferencia. Como era muy crítico del rol del Ministerio de Salud y la organización hospitalaria, un día me miró a mí, pensó un instante y dijo: “Y a Pracilio, lo estamos preparando para Ministro”. Su intención nunca se cumplió.



La última víctima de la dictadura: No puedo

dejar de mencionar aquí la tragedia que rodeó los últimos años de vida de Jorge Salvioli, que todos los que lo rodeábamos y apreciábamos no solo como maestro, como docente apasionado por la enseñanza, como estudioso y médico prestigioso, sino también como persona afable, empático con sus pacientes y discípulos, vivimos como un drama que nunca olvidaremos. En agosto de 1976, cuando transcurría el momento más importante de su vida profesional, como Profesor Adjunto de la Cátedra, Presidente de la Sociedad Médica de La Plata, con varios libros escritos y solicitado disertante de eventos médicos, Salvioli es secuestrado en su casa, ante su esposa e hijos, por un grupo de tareas del Ejército. Aunque su desaparición fue solo durante 24 horas, ya que fue liberado encapuchado en el bosque de La Plata junto a otros colegas que habían sufrido la misma suerte, el impacto entre sus colegas, amigos y familiares fue enorme, sobre todo porque hacía solo una semana que había sido dado de alta de una operación de vesícula. Nunca supimos la razón de su secuestro y rápida liberación, sobre todo porque Jorge estaba muy lejos de participar en ninguna actividad política, y él nunca quiso hablar del momento y muy probables apremios ilegales recibidos. Tal fue la indignación que nos produjo el hecho, que luego de su liberación yo preparé una solicitada dirigida al Gobernador del proceso, General Ibérico Saint Jean, para publicar en El Día, denunciando el hecho por el “respeto a los derechos humanos”... (!!). Varios colegas de la Cátedra y del Hospital estuvieron dispuestos a firmarlo, pero gracias a la prudencia del Dr. Manzino, que me sugirió consultarlo con el mismo Salvioli, internado entonces en el Hospital Español producto de una sepsis a partir del stress padecido, quién me agradeció el gesto pero me pidió no publicarla, creo que quizás nos salvó la vida a los posibles firmantes. Es posible que el diario tampoco la hubiera publicado. Jorge falleció de una neoplasia de vía biliar siete años después, o sea aproximadamente el tiempo que sabemos lleva un cáncer para desarrollarse luego de un fuerte trauma psicológico. Su muerte ocurrió el 7 de diciembre de 1983, o sea tres días antes de la asunción del Presidente Alfonsín, por lo cual considero que Jorge Salvioli fue la última víctima de la dictadura cívico militar más sangrienta que vivió nuestro país.



La etapa de formación y ejercicio profesional de la medicina asistencial fue amplia y diversa. A poco de recibirme tuve la oportunidad de ejercer en Ensenada como uno de los primeros médicos de cabecera del PAMI, que recién se implementaba en el país, tomando como modelo el sistema inglés de “general practitioner” (médico general). Fue una excelente experiencia para mi formación clínica y para el ejercicio de una medicina muy personalizada para las personas mayores, a quienes tenía que atender en consultorio y domicilio, cumpliendo la tarea del viejo médico de familia que comencé a defender desde entonces. Además de la guardia en el Hospital de Ensenada, hice domicilios en el Instituto Ferroviario y fui auditor médico durante 27 años en La Plata de una Obra social nacional de personal de dirección. Como al mismo tiempo había comenzado a formarme en Salud Pública y ejercer la docencia en la Cátedra de Higiene, Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, todo ello fue un enorme aprendizaje para conocer desde la propia experiencia las ventajas y defectos del sistema de salud en los tres subsectores, estatal, privado y de la seguridad social. Pude apreciar directamente las barreras a la accesibilidad de todo tipo, las deficiencias y problemas en la calidad de los servicios, las diversas formas de corrupción que se daban en todos los modelos de atención, como la sobreprestación y sobrefacturación en los sistemas de remuneración por acto médico, o la subprestación en los sistemas capitados o salariales.



Seguro de salud vs seguro de enfermedad: En 1978, en plena época del proceso, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires organizó un gran encuentro interdistrital para analizar el proyecto de “Seguro de Enfermedad” que estaban preparando para extender la cobertura de la seguridad social, en especial para garantizar el acceso de más población al sector privado. Me ofrecí y me asignaron para representar a la Cátedra en dicha reunión, y fue mi primera oportunidad de expresarme públicamente en un foro no docente, ante médicos de toda la provincia. Fuí la única voz en todo el encuentro en oponerme al “seguro de enfermedad”, argumentando desde el indiscutible fundamento sanitario que

si el seguro solo financiaba la atención de la enfermedad, cada vez habría más enfermos que atender. Que el proyecto debía cambiarse por un “Seguro Integral de Salud”, que debía financiar prioritariamente las acciones de promoción y protección de la salud, en base a la estrategia de la atención primaria de la salud. Esta no debía considerarse solo limitada al sector público, sino que también debían practicarla los médicos del sector privado, especialmente con la figura del médico generalista o de familia y otros profesionales del primer nivel de atención como pediatras, clínicos, obstetras, etc. Creo que algunos médicos aplaudieron..., no muchos.



De la misma forma que lo fue en la medicina asistencial, las experiencias extracurriculares también fueron muy importantes en mi formación como médico sanitarista. Por entonces, la única opción universitaria para la especialidad era la Escuela de Salud Pública de la UBA, y en 1980 me gradué como Diplomado en Salud Pública, después de asistir a un curso de 1200 horas viajando todos los días a Buenos Aires, mientras seguía con el consultorio en Ensenada.



El dilema de la especialidad: Después de diez años de ejercicio de la clínica médica, con buenos resultados desde el punto de vista económico y de aceptación por parte de mis pacientes, se me presentó la crisis del posible cambio de especialidad, porque ya ejercía la docencia de salud pública en la Facultad, trabajaba en el Ministerio de Salud y trataba de continuar mi formación en el campo sanitario. Entonces hice lo que todo buen discípulo debe hacer cuando reconoce a su Maestro, decidí consultarlo y fui a ver al Dr. Manzino a su propia casa y le dije cuál era mi dilema: seguir ejerciendo la clínica médica o dedicarme de lleno a la medicina sanitaria. La respuesta de Manzino fue para mí otra de sus grandes enseñanzas que recuerdo y valoro hasta hoy. “Dígame, Pracilio: cuándo usted vuelve a su casa por la noche, o cuando tiene tiempo de leer medicina, ¿qué lee?, ¿clínica médica o salud pública? La pregunta no me dejaba opción, y le respondí con sinceridad: “Salud Pública”. Su respuesta fue inmediata y contundente: “Entonces

deje el consultorio, porque usted se va a desactualizar rápidamente y ya no será buen médico como lo es hasta ahora. Pero no lo haga en forma inmediata. Informe primero a sus pacientes uno por uno las razones por las que no va a atender más, y qué colega les recomienda para que lo reemplace". Reconozco que no lo hice con todos, y aún siento culpa por ello, pero a fin del año 1983 dejé para siempre el consultorio. Precisamente con el retorno de la democracia, antes de cumplir los 40 años, inicié una nueva etapa de vida profesional que continúa hasta hoy.



El mensaje implícito en el consejo del Dr. Manzino era claro, y fue otro de los que repetí rigurosamente a todos los alumnos que pasaron por mi Cátedra: *"La medicina es un estudio para toda la vida"*. Pero dada su complejidad actual, esto también rige para la formación en la especialidad que cada uno ha elegido, que actualmente requiere siempre de estudios de posgrado. Sin embargo, como nos proponía Salvio, y también según mi propia experiencia, siempre he recomendado que la formación en una especialidad debe ir siempre acompañada de un período previo o paralelo de experiencia en alguna forma de medicina integral: medicina general o familiar, pediatría o clínica médica. Recién entonces se puede ejercer con más seguridad alguna especialidad, ya sea en forma definitiva alguna de las mencionadas, profundizar en alguna sub-especialidad, o aquella que cada uno decida para su futuro profesional. Las especialidades quirúrgicas también requieren de un entrenamiento previo en clínica médica o quirúrgica, que implique una amplia práctica de la semiología, el diagnóstico por imágenes y de la relación médico paciente. Ningún médico especialista puede ignorar los aspectos básicos de la medicina centrada en la persona, porque salvo el patólogo y el forense, todos los demás atienden seres humanos en plena vitalidad, cualquiera sea su problema o patología, que las afectan en su integridad bio-psico-social.

En conclusión, al igual que con la clínica médica, más allá del título universitario de posgrado, fueron las experiencias del trabajo asistencial, la docencia en la especialidad, y la práctica de la medicina sanitaria a nivel institucional, las que

me formaron para poder desarrollar, a partir de la recuperación de la democracia, importantes responsabilidades en la docencia universitaria y en la función pública, que completarán esta historia de vida profesional.

30 años de educación médica centrada en la comunidad

El retorno de la democracia a nuestro país, a principios de la década de los 80, no solo significó una recuperación del sustento político y jurídico del Estado, que devolvió la vigencia de los derechos humanos, sociales y políticos a los argentinos, sino que también permitió iniciar un nuevo proceso de democratización de las instituciones básicas de la sociedad y el Estado. Así, la Universidad argentina fue de las primeras en iniciar un proceso de normalización institucional para retornar al modelo de gestión participativa impuesto por la Reforma Universitaria de 1918. Al mismo tiempo, se comenzó el debate sobre los necesarios cambios curriculares de las carreras de grado, para adecuar la formación de los profesionales a las verdaderas necesidades de la comunidad.

La Universidad Nacional de La Plata fue entonces el escenario privilegiado de los debates por el rol de la Universidad pública en la recuperación democrática, y la Facultad de Ciencias Médicas no fue entonces una excepción a la búsqueda de una transformación del modelo curricular vigente, para orientar la educación médica hacia la formación de médicos comprometidos con la realidad social y el cuidado integral de la salud individual y colectiva.

Por decisión del Consejo Académico Normalizador, la Comisión Curricular y el Decano Normalizador, Dr. Oscar Giacomantone, se crea una materia propedéutica con contenido humanístico y social, denominada "Salud, Medicina y Sociedad", que diera inicio a un cambio curricular orientado a la formación de un médico general para la atención primaria de la salud. Como correspondía a los nuevos aires democráticos, y aunque se trataba de una materia propedéutica experimental, todos los cargos de la nueva Cátedra fueron asignados por concurso de antecedentes y oposición. Nos presentamos seis postulantes, algunos de amplia trayectoria sa-

nitaria, pero tuve el honor de ser elegido Profesor Titular, por un jurado integrado por profesores, alumnos y graduados comprometidos con la necesidad de un cambio curricular. Como Profesores Asociados fueron designados en el área de Epidemiología la médica sanitarista Dra. Myrtha Escudero, en Antropología el Lic. Mario Virgolini, que continúa hasta hoy en la Cátedra, en Introducción al Método Científico el Dr. Luis Dapino, en Deontología Médica el Dr. Alberto Bertoldi, y en Introducción a la Psicología Médica el Dr. Herbert Chappa, todos prestigiosos profesionales de La Plata, y cada uno acompañado con un equipo de Auxiliares Docentes.



La lucha contra el cadáver: El 8 de abril de 1985 se inicia el primer curso para un grupo de más de tres mil ingresantes a la carrera de medicina, ya que la Universidad había retornado al modelo de ingreso irrestricto. El desafío fue muy grande a partir de una Cátedra nueva, con destacados Profesores Asociados y algo más de 30 docentes de distintas disciplinas, hecho totalmente inédito en la Facultad. Tuve el privilegio de ser el primer Profesor de toda la Facultad en dar la clase de recepción a los alumnos en el Aula Magna, lo que me obligó a repetirla los cinco días de la semana con la misma repleta de alumnos. Además de presentar la materia y las características del curso, aproveché tan excelente oportunidad para tratar de lograr la impronta en los alumnos de un modelo de medicina humanizada, preventiva y social, orientada a la persona, la familia y la comunidad, tratando de contrastarla con mi experiencia de hacía veinte años al ingresar a la Facultad. Recuerdo haber utilizado la ironía del absurdo para marcar la diferencia: “Es posible que en alguna Cátedra de Anatomía les digan que si alguno de ustedes no soporta ver los cadáveres, sus órganos y el olor a formol, no está en condiciones de estudiar medicina. Yo les digo lo contrario, que solo haría ingresar a la carrera aquellos alumnos que se sensibilizan ante la visión de la muerte. En esta Cátedra tendrán la oportunidad de tener una primera experiencia con las personas vivas en su verdadero entorno, saliendo a investigar los problemas en su propia comunidad”.



Sin embargo, el esperado cambio curricular para extender el modelo bio-psico-social a lo largo de toda la carrera de medicina, nunca se llegó a concretar en los más de treinta años desde el comienzo de la etapa democrática, a pesar de varios intentos en los que siempre fui promotor y protagonista de alguna forma. A pesar de las recomendaciones de las entidades científicas y de educación médica, organismos internacionales y nacionales de educación y salud pública, solo a partir de las exigencias de la CONEAU para la acreditación de la Facultad, se decidió un cambio del Plan de Estudios que comenzó a regir en 2004, que actualmente padecen los estudiantes, y que nada tiene que ver con las mencionadas recomendaciones. El principal motivo ha sido la resistencia del mismo claustro docente, mayoritariamente formado por docentes de las materias biomédicas y clínicas. Nunca más precisa la sentencia del epidemiólogo norteamericano Kerr White al respecto: “Cambiar el currículo de una Facultad de Medicina es tan difícil como trasladar un cementerio, porque los de adentro no colaboran”.



Otra batalla perdida: En 2000 la Facultad se somete al proceso de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU), la cual en su informe respecto al Plan de Estudios y Formación, señala la “necesidad de reforzar los contenidos y acciones de atención primaria de la salud”, así como de lograr una “mayor participación de los alumnos en actividades prácticas, en especial en los primeros años, referidos al tema de atención primaria de la salud, con concurrencia a hospitales de diferente complejidad y Centros de Salud”, destacando en tres partes del informe la tarea de la Cátedra de Salud, Medicina y Sociedad en tal sentido. En 2001, en el marco del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS), el Ministerio de Salud de la Nación decide apoyar a las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario para que realicen reformas curriculares orientadas a fortalecer la formación del médico en atención primaria de la salud. La Facultad se compromete a incorporar, en la reforma curricular en marcha, módulos de Atención Primaria de la Salud, con el fin de fortalecer

la formación del estudiante para la APS y la salud de la familia. El Decano de la Facultad me encomienda la coordinación del proyecto, ante lo cual con la participación de otros Profesores se elabora una propuesta curricular basada en la creación de áreas de integración a lo largo de toda la carrera, utilizando las modernas metodologías pedagógicas del aprendizaje basado en problemas y la educación centrada en la comunidad. Sin embargo, esta propuesta no es considerada ni incorporada por la Comisión Curricular en el nuevo Plan de Estudios, que comienza a regir a partir del año 2004. El nuevo Plan reduce a cinco años la duración de la carrera de medicina, con un año de Práctica Final Obligatoria, y la materia Salud, Medicina y Sociedad pasa a denominarse "Salud y Medicina Comunitaria", pero con una reducción del 40 % de su carga horaria, por lo cual algunos contenidos pasan a desarrollarse en dos materias optativas. O sea que la Facultad hace exactamente lo contrario a las recomendaciones de la CONEAU, y cambió el Plan de Estudios sin cambiar el modelo curricular.

— * —

A pesar de las mencionadas limitaciones curriculares, la Cátedra de Salud, Medicina y Sociedad, luego Salud y Medicina Comunitaria, fue desarrollando su actividad docente según el modelo pedagógico de la educación centrada en la comunidad, propuesto en 1987 por la OMS a partir de numerosas experiencias de escuelas de medicina de todo el mundo. En 2001 tuve oportunidad de asistir al Congreso Mundial de Educación Centrada en la comunidad, en Londrina (Brasil), con la participación de Facultades de Medicina de todos los continentes, apreciando con satisfacción las bondades de un modelo pedagógico que nosotros estábamos utilizando había más de quince años. Del mismo modo, en una visita que hice al Departamento de Salud Pública de la Universidad "George Washington", en ocasión de una consultoría en la OPS, me mostraron cómo habían implementado el enfoque basado en el ciclo de vida en su modelo curricular, tal como lo estaba haciendo nuestra Cátedra desde el primer momento.

Cabe destacar que en la lucha por el cambio curricular, y en la aplicación del modelo

de enseñanza centrada en la comunidad, humanizado, preventivo y social, no hemos estado solos en nuestra Facultad, pero han sido muy contadas excepciones. Una de ellas, quizás la más importante y con una larga historia anterior a la aparición de nuestra Cátedra, ha sido la Cátedra de Pediatría "B", que desde Noel Sbarra, en el Hospital que hoy lleva su nombre, con el liderazgo científico y docente de Marcos Cusminsky, sus continuadores Luis García Azzarini, Roberto Mateos y María Alicia Marini, hasta casi todos sus discípulos, ha sido un modelo en el campo de la salud infantil. En realidad, en mi formación y ejercicio de la medicina sanitaria, debo reconocer que han sido los pediatras los que más me han enseñado las bases de una medicina social orientada a la atención primaria, familiar y comunitaria.

— * —

Una nueva oportunidad: Afortunadamente, en 2008 el Consejo Académico toma una decisión que inesperadamente le da a la Cátedra la oportunidad de desarrollar una nueva experiencia pedagógica, esta vez en el último año de la carrera. Se decide la incorporación en la Práctica Final Obligatoria de un módulo de prácticas en el primer nivel de atención, aunque desafortunadamente se lo denomina "Consultorio Externo Periférico", cuyo dictado se encomienda a la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria. Por sus contenidos teóricos y prácticos, proponemos que este Módulo sea denominado como "Medicina General, Familiar y Comunitaria", el cual comienza a dictarse en 2009. Desde entonces, además de las prácticas hospitalarias de Clínica, Pediatría, Ginecología y Cirugía, todos los practicantes realizan prácticas de APS en los CAPS de varios municipios de la región, y con la tutoría de colaboradores docentes de los mismos y la supervisión de docentes de la Cátedra, en general médicos generalistas. Esta experiencia con los alumnos del último año fue muy gratificante para todo el equipo docente que lo llevamos adelante y especialmente para mí, ya que al ser el último Profesor de la Facultad en tener un contacto con los practicantes antes de realizar el trámite para la obtención del título, aproveché la oportunidad para entrevistarlos, uno por uno o en pequeños grupos, y ofrecerles algunas recomendaciones

finales para el ejercicio profesional. La mayoría de ellas eran las enseñanzas éticas que había aprendido de mi maestro, el Dr. Manzano, y otras de mi propia experiencia personal.



Otra de las experiencias más enriquecedoras desde el punto de vista docente, y también humano, ha sido la oportunidad de organizar, dirigir o coordinar cursos de posgrado en distintas instituciones desde la década del 80 hasta la actualidad, en el campo de la Salud Pública, la atención primaria y la Administración de Salud. Para mencionar solo algunos, entre 1995 y 1996 desde la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria desarrollamos un Curso de Especialización en Salud Pública en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito I), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, y también varios cursos de Administración Estratégica de los Sistemas Locales de Salud en distintas ciudades y con distintas instituciones de varias provincias argentinas.

Aunque se desarrollaron varios proyectos de investigación, en general estudios epidemiológicos, la principal fortaleza de la Cátedra ha sido la extensión universitaria, con numerosos proyectos acreditados y subsidiados por la Universidad Nacional de La Plata en sus convocatorias anuales, como también otros reconocidos y financiados en el marco de programas del Ministerio de Salud de la Nación, de la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones. En conjunto con otras Unidades Académicas de la UNLP, se desarrollaron varios proyectos de extensión sobre diversas problemáticas y en distintos ámbitos comunitarios. Entre otros, La Plaza de la Salud, Los Mayores Primero y El desafío de prevenir la violencia.

A partir de 1998, con la creación en la Facultad de Ciencias Médicas el Centro Interdisciplinario Universitario para la Salud (INUS), bajo la dirección del Dr. José María Paganini, con la participación de todas las Cátedras del área social, se desarrollan varios proyectos de posgrado, extensión universitaria y asesoría en Salud Pública. En base a la propuesta pedagógica que había realizado en OPS sobre “Educación en Administración Estratégica de los Sistemas Locales de Salud”, se diseña la

Maestría en Salud Pública con tres orientaciones, haciéndome cargo de la Dirección de la Maestría con orientación en Sistemas Locales de Salud. A partir de 2004 llevamos a varias provincias argentinas el Programa de Educación Continua a distancia en Medicina General Familiar (MGF21), y en base a un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, me toca co-dirigir el Posgrado de Salud Social y Comunitaria para profesionales del primer nivel de atención, también en varias provincias y municipios.

El principal programa de asesoría y extensión universitaria que se llevó a cabo en el INUS, que me tocó diseñar y coordinar, fue el de “Enseñanza y práctica de una nueva salud pública para la promoción de la salud en el municipio”, denominado Proyecto SIMBEL (Salud Integral Municipal para Berisso, Ensenada y La Plata), realizado con el apoyo de la Fundación W.K.Kellogg, que fue reconocido por la OPS como el primer proyecto para el desarrollo de Municipios Saludables en la Argentina.

Por último, la Cátedra que tuve el honor de conducir durante más de treinta años como espacio académico en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, ha organizado o participado de varios eventos vinculados con la salud pública o comunitaria. Entre ellos, merecen destacarse los siguientes: en primer lugar, la organización del II Congreso Argentino de Medicina Familiar, realizado en nuestra Facultad en octubre de 1986; el Primer Encuentro de Salud y Medicina de los Pueblos Indígenas, en la localidad de Toay, Provincia de La Pampa, en mayo de 1994, y varios Seminarios de Promoción de la Salud de la Maestría en Salud Pública, el último de los cuales se realizó en abril de 2015. en el marco del 30 Aniversario de la Cátedra.

En conclusión, a pesar de la idea original de la creación de la Cátedra fue contribuir a la transformación curricular desde un modelo biomédico basado en la atención médica de la enfermedad, a un modelo bio-psico-social orientado al cuidado primordial de la salud, la misma aún no ha podido concretarse. No obstante, junto con el equipo docente de la Cátedra que me acompañó a lo largo de estos más de treinta años, nos sentimos orgullosos de haber sido protagonistas de una experiencia pionera en la Argen-

tina en cuanto a la incorporación de las ciencias sociales en los primeros años de la carrera de Medicina, y en el desarrollo en una estrategia pedagógica centrada en la comunidad. A partir de los años 2000 esta propuesta se extiende a otras facultades de medicina del país, en particular en las nuevas Universidades, tendiente a formar médicos con una visión humanística, un enfoque integral de la salud y una práctica profesional con base ética y compromiso social.

A partir de 2006 tuve un nuevo desafío y la oportunidad de contribuir al desarrollo y la instrumentación del nuevo modelo curricular en la carrera de medicina de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Olavarría. Por invitación del Decano Dr. Héctor J. Trebucq, y con la ventaja de contar con un equipo docente formado a partir de la sub-sede de la Cátedra de La Plata que funcionaba en esa ciudad desde 1995, me integré al equipo docente de esa Universidad. Desde el inicio de la carrera me desempeñé como Jefe del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública, y actualmente a cargo del Módulo de Medicina General, Familiar y Comunitaria de la Práctica Final Obligatoria. Esta experiencia que lleva ya más de quince años, con un desarrollo del área social a lo largo de toda la carrera, representó para mí una compensación por la larga lucha llevada a cabo en la Facultad de La Plata, donde me jubilé sin poder ver concretado el tan ansiado cambio curricular.

Una experiencia de democracia participativa

Con el retorno de la democracia en 1983, como tantos otros argentinos, asumo la militancia política activamente dentro de los espacios profesionales y sanitarios del justicialismo. Pero a partir del triunfo del Alfonsín, que considero que fue lo mejor para el país en ese momento, adhiero fuertemente a la propuesta de renovación de Antonio Cafiero, por lo que me sumo a colaborar en el bloque renovador del Senado Provincial, como asesor de la Comisión de salud. Ante el triunfo de Antonio para la Gobernación, me integro al CEPARJ (Centro de Estudios para la Renovación Justicialista), en el equipo de salud de mi maestro, el Dr. Floreal Ferrara, quién me invita a participar de la nueva gestión en

el Ministerio de Salud. En principio, Floreal me ofrece la Subsecretaría de Medicina Social, o sea una de las dos Subsecretarías del Ministerio, honor que resigno para poder trabajar en el área de mi formación, la planificación sanitaria, en la que venía trabajando como profesional. Desde hacía más de diez años. Aceptando mi decisión, con la asunción del gobierno en diciembre de 1987, me designa como Director de Planeamiento y Desarrollo, la que proyectaba elevarla a la jerarquía de una nueva Subsecretaría. En razón de mi pertenencia al Ministerio, me asigna junto a José Tagliafico, que sería luego el Subsecretario de Salud Pública, la tarea de participar en el proceso de transición, en la cual todos los Directores de la gestión anterior me brindaron su absoluta colaboración.



Una consultoría muy oportuna: *Un mes antes de comenzar la gestión en el Ministerio Provincial, fui invitado por otro de mis maestros en el campo sanitario, José María Paganini, quién me había permitido iniciar mi carrera en el Ministerio de Salud Pública provincial, a realizar una consultoría en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington D.C. Paganini había sido docente de la Cátedra de Higiene, Medicina Preventiva y Social de la Facultad, y co-autor del libro “Medicina Comunitaria” junto con Floreal Ferrara, texto de referencia para estudiantes y docentes de salud pública. En ese momento, Paganini se desempeñaba como Director del área de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, y era el principal propulsor del desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), estrategia sanitaria en el marco de la democratización de los países de las Américas que se estaba dando en la década de los 80, orientada al fortalecimiento de los gobiernos locales. Tuve el honor de participar entonces en un grupo de trabajo con otros compañeros latinoamericanos sobre el tema “Participación social en los Sistemas Locales de Salud, que significó un aporte fundamental a la política de los SILOS, y que estaba en total sintonía con la política del gobierno al cual me incorporé a los pocos días de volver de la consultoría. Al terminar la gestión política en el Ministerio, Paganini me invitó varias veces a participar de consultorías en Washington D.C., siempre sobre el tema de los Sistemas Locales*

de salud, y al jubilarse se integró a la Facultad de Ciencias Médicas como Director del Centro INUS.



Al iniciarse la gestión del Ministro Ferrara, en diciembre de 1987, la tarea más importante que me encomienda como Director de Planeamiento fue colaborar en la puesta en marcha del programa ATAMDOS (Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud), un programa absolutamente innovador en el campo de la atención primaria, basado en la doctrina sanitaria de Ramón Carrillo, con algunos componentes de otras experiencias internacionales, pero adaptado a la realidad de nuestro país y de la Provincia de Buenos Aires. A partir de la conformación de los equipos de salud familiar y comunitaria, integrados por médico generalista, enfermero, trabajador social y psicólogo, con dedicación exclusiva para el primer nivel de atención, este programa estaba destinado a producir una profunda transformación en el modelo de atención primaria provincial, en su mayor parte en manos de los municipios. El ATAMDOS era parte de una propuesta más amplia denominada Sistema de Atención Progresiva de la Salud (SIAPROS), una idea adelantada del actual concepto de Redes en Salud, pero que no llegó a desarrollarse por la prematura renuncia de Ferrara.



Los desafíos del ATAMDOS: Al comienzo de la gestión del gobierno, la Provincia de Buenos Aires contaba con más de 1000 Centros de Salud, la mayoría municipales, pero aún estaban bajo dependencia directa del Ministerio de Salud solo algo más de 100 CAPS, casi todos del llamado Plan Muñiz. Por lo tanto, las posibilidades de implementación de un programa de atención primaria en todo el ámbito provincial, dependía de un acuerdo con los municipios, que Ferrara lo logró con varios intendentes afines al gobierno provincial, pero la mayor parte de los equipos se instalaron en los CAPS que dependían del Ministerio. En los 100 días que duró la gestión de Ferrara a cargo del Ministerio se pusieron en marcha más de 150 equipos de salud en distintos municipios de casi todas las regiones del territorio provincial, tanto en aquellos del conurbano como Florencio Varela y Merlo, como del

interior de la provincia como Pedro Luro, Punta Alta, Salto, Tandil y otros. Cada equipo de salud familiar y comunitaria estaba formado por un médico generalista, una enfermera, un administrativo, un trabajador social y un psicólogo; cada dos equipos, contaba con un odontólogo. El ATAMDOS incorpora, quizás por primera vez en la provincia, el concepto de “población a cargo”, o “población bajo responsabilidad”, definido por Bárbara Starfield como uno de los atributos fundamentales de la atención primaria. Cada equipo tenía a cargo 300 familias, unas 1200 a 1500 personas, para lo cual atendían entre ocho y diez horas por día en cada CAPS. Todos los cargos eran de dedicación exclusiva, con retención de título a los profesionales, y el sueldo era equivalente al del Ministro, hecho inédito e irrepetible en el sistema de salud. El ATAMDOS fue muy bien recibido por las comunidades que de un día para el otro se encontraron con un centro de salud en su barrio que funcionaba ocho o diez horas diarias con un equipo completo de salud, y además les permitía participar en la gestión cotidiana de las acciones a emprender, a partir de una de las apuestas fuertes del programa a la participación comunitaria: la asamblea de vecinos, que orientaba la actividad, participaba en las decisiones presupuestarias, y viabilizaba las necesidades de la comunidad local. Sin embargo, y seguramente por lo revolucionario de este programa, el ATAMDOS se constituyó en uno de los focos de conflicto para la gestión, en varios frentes tanto políticos como sanitarios. En primer lugar, los Intendentes municipales percibieron al programa como una injerencia política inconsulta en sus territorios, a partir de la movilización comunitaria alrededor de los CAPS. Comenzaron a preocuparse porque los CAPS provinciales o aquellos municipales que se habían incorporado al programa, competían fuertemente con los otros CAPS que continuaban con el modelo tradicional de atención limitada en horario y personal, y las diferencias salariales entre los profesionales provinciales y municipales. La gente se desplazaba muchas cuadas, a veces de un municipio a otro en el conurbano, para ser atendido por un equipo ATAMDOS en horario vespertino. Fue tanta la demanda espontánea que a veces los equipos no alcanzaban a realizar las visitas domiciliarias que eran parte del programa. También fue resistido por los Directores de hospitales, que veían perder el

control de la atención médica local, así como por los profesionales de carrera hospitalaria, que veían jerarquizada la tarea de los profesionales de los CAPS. El propio Ferrara relata en una entrevista realizada tiempo después las dificultades que habían tenido en la implementación de los equipos: “Tuve grandes dificultades con los radicales, con los curas, los pastores evangélicos, porque sintieron que les robábamos poder. Ellos eran los dueños del dolor, de la derrota, los dueños de las necesidades, y ahora el Atamdos se estaba apoderando de eso” (Svampa, 2010). Confesó que lo bombardearon en todas partes, menos los curas católicos. Finalmente, el costo del programa en el marco de una difícil situación financiera provincial, los problemas políticos y la prematura renuncia de Floreal al Ministerio, impidieron la integración del programa a la estructura del sistema de salud y limitaron su continuidad y extensión dentro de la provincia.



El conflicto por el ATAMDOS no fue el único durante la gestión de Ferrara. Cuando en febrero de 1988 el ministro denunció, en una nota periodística, la práctica generalizada de cesáreas como un genocidio, la Federación de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) lo tildó de “ministro rojo”. Los diarios provinciales, El Día de La Plata y Nueva Provincia de Bahía Blanca le hicieron una campaña de desgaste (Medina, 2019). Finalmente, una acusación de corrupción contra su mujer desencadenó su renuncia, cuando habían pasado un poco más de tres meses desde la asunción. Todo el gobierno consideró que la denuncia fue una operación política promovida por la corporación médica, pero de todos modos Ferrara renuncia para no afectar la imagen del gobierno recién iniciado. Cafiero rechaza la renuncia y le otorga una licencia por el tiempo que fuera necesario hasta que la justicia se expida sobre el caso, quedando a cargo del despacho el Ministro de Asuntos Agrarios, Ing. Felipe Solá. No obstante, luego de cuatro meses, cuando Cafiero pierde la elección interna para Presidente con Menem, sin novedades en la causa judicial, el Gobernador se ve obligado a aceptar la renuncia, nombrando en su lugar al médico sanitarista Ginés González García.

*

El conflicto por las cesáreas: A los pocos días de asumir, otra de las tareas que me encomendó el Ministro, dada mi responsabilidad en las estadísticas sanitarias, fue procesar la información sobre la frecuencia de las cesáreas en los establecimientos de la provincia, públicos y privados. A partir de los resultados, Ferrara hace su famosa denuncia sobre el exceso de cesáreas por parte de clínicas, sanatorios y médicos privados, generando una fuerte reacción en la corporación médica, acusando al Ministro de iniciar una persecución a la medicina privada. Por haber sido testigo privilegiado de este hecho que tuvo gran impacto mediático y político, quiero aportar algunas precisiones sobre lo ocurrido en esa oportunidad. Los datos de cesáreas eran tan sorprendentes y generalizados, que el Ministro decidió citar al Ministerio a los Directores de Clínicas que tuvieran por encima del 50 %, o sea fuera de todo lo razonable. La reunión se hizo en la Sala de Situación, repleta de empresarios médicos de toda la provincia, y algunos dirigentes de entidades médicas. Luego que yo terminé de presentar los datos, el Ministro se dirigió a quién estaba a su derecha, el Profesor Titular de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, Prof. Dr. Guillermo Coccozzella, que había sido especialmente invitado, y le preguntó cuánto consideraba la proporción de cesáreas aceptables en una población, incluyendo los partos de riesgo. El Dr. Coccozzella, sin dudar, dijo que no debería superar el 15 %, cifra que era el promedio de los hospitales públicos de la provincia, algunos de los cuales tenían una alta proporción de partos de riesgo. Con su habitual gesto de desafiante seriedad, miró a todos los presentes y les pidió que explicaran la razón de que sus establecimientos tenían entre 50 y 70 % de cesáreas, y también a los dirigentes médicos por los altos porcentajes individuales de muchos médicos privados. Nunca olvidaré las numerosas hipótesis y excusas con lo que los Directores de las clínicas trataron de justificar lo injustificable: el pedido de las parturientas, los tiempos de los médicos, la medicina defensiva. Pero lo que más me llamó la atención es que la mayoría de los Directores dijeron “no tener control sobre lo que hacen los médicos en sus establecimientos...” (¡!). La conclusión fue que los establecimientos privados, salvo excepciones, no tienen ningún mecanismo de evaluación o auditoría de calidad

de la atención médica. De esta reunión los médicos no se llevaron más que una reprimenda y exhortación del Ministro a tomar cartas en el asunto para corregir esta situación, pero al otro día en un reportaje periodístico Ferrara denunciaba con duras palabras esta “mala praxis” obsesiva masiva. Pocas semanas después, Ferrara presenta su renuncia al cargo por razones personales, pero en el gobierno y en todo el equipo nadie dudaba que fue una operación política promovida por las entidades médicas.



Al concretarse la renuncia de Floreal Ferrara por razones personales, asume Ginés González García como nuevo Ministro de Salud, que había sido socio de Floreal en la consultora “CONCISA”, pero la propuesta no la hace Ferrara sino Felipe Solá, Ministro de Asuntos Agrarios. Aunque no me conocía, Ginés me confirma en el cargo por recomendación de Floreal, y luego de una reforma de la estructura ministerial que se hace a los dos años del gobierno, me designa como Director General de Planificación. En el marco de las políticas globales del gobierno provincial, el Ministro propone trabajar en la instrumentación de la descentralización del sistema de salud, lo que para mí fue una gran oportunidad a partir de la experiencia y el trabajo realizado en la OPS sobre los Sistemas Locales de Salud (SILOS). En el caso de nuestra provincia, la descentralización significaba fortalecer el rol de los municipios en la salud, acorde con toda la política del gobierno provincial.

El sello distintivo de la gestión del Gobernador Antonio Cafiero fue el desarrollo de una verdadera **democracia participativa**, cuyos pilares de política pública fueron **la planificación, la descentralización, la participación y concertación social**. Sus formas instrumentales se manifestaron en todas las áreas y actos de gobierno, e iban a quedar consagradas en la nueva Constitución Provincial, una verdadera joya de política constitucional, lamentablemente frustrada por el resultado del plebiscito, mediáticamente provocado. La política de participación social se expresó en el **Consejo para el Desarrollo y la Participación Provincial**, integrado por todas las fuerzas que protagonizan el quehacer social y económico de la Provincia,

en los **Consejos de Escuela**, en los **Consejos de Seguridad**, en el **Consejo Provincial de la Mujer**, en las jornadas de trabajo voluntario con la participación de vecinos y municipios, y hasta en las cárceles se instrumentó la participación de los propios internos para mejorar sus condiciones de reclusión. También los procesos de planificación se instrumentaron en forma participativa, en particular el **Plan Trienal de Gobierno**, que se construyó a partir de diversos ámbitos de participación ciudadana. Y aunque la oposición política, como corresponde a la democracia, tuvo los organismos de control del Estado bonaerense, no hubo ninguna denuncia de corrupción en los cuatro años de gobierno.

Cafiero definía la filosofía política de su gobierno en la convicción de que *“la sociedad no es necesariamente conflictiva sino posiblemente armónica”*, y decía que desentrañar esas armonías naturales es la gran tarea del estadista. Por ello la gestión provincial de Antonio Cafiero, en el contexto de la renaciente democracia política nacional, fue un modelo de avanzada en la idea de una democracia deliberativa, donde lo esencial no es solo la libertad de elegir los gobernantes, sino de opinar, de manifestarse pacíficamente, de participar en las decisiones que nos afectan, entendiendo a **la democracia como un modo de vida, y no solo como una forma de gobierno**.

En consonancia con la política del gobierno provincial, El Ministerio de Salud comienza a desarrollar la descentralización en distintos niveles: provincial, regional, municipal e institucional. A **nivel provincial**, con la conformación del **Pacto Social de la Salud**, un consejo consultivo para la concertación de las políticas provinciales de salud, con la participación de todas las instituciones y organizaciones del sector de alcance provincial; a **nivel regional**, con la creación de la Subsecretaría de Descentralización Regional, tendiente a la desconcentración administrativa mediante el fortalecimiento de las Regiones Sanitarias; a **nivel municipal**, a través del **Programa “Pro-Salud”** de planificación estratégica participativa; y a **nivel institucional**, mediante la Ley 11072/90 de **Descentralización Hospitalaria**, que incorporó la participación de los profesionales, los no profesionales y la comunidad en la gestión hospitalaria, que se inició

en 1991 con la descentralización de 13 hospitales provinciales. También se concretó la transferencia de las Unidades Sanitarias provinciales a los municipios, y se fortaleció su gestión mediante el programa **“Salud con el pueblo”**.

El **Programa “Pro-Salud”**, orientado al **Desarrollo de los Sistemas Municipales de Salud**, fue una experiencia innovadora que se adelantó en muchos años a la propuesta de “municipios saludables” de la OMS/OPS. A partir de mi trabajo en OPS sobre los SILOS, desde el área de planificación del Ministerio elaboramos este programa teniendo en cuenta la realidad territorial, jurídica y política de la Provincia de Buenos Aires. Su principal componente fue la propuesta de creación de los **Consejos Municipales de Salud**, que debía ser presidido por el Intendente Municipal, e integrado por los funcionarios provinciales y municipales responsables de los servicios y programas de salud en el distrito, representantes de organizaciones comunitarias, asociaciones profesionales, obras sociales, sector privado y otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud. Este Consejo era un ámbito de planificación, participación y concertación, con el objetivo de favorecer la comunicación y la articulación entre los actores sociales locales para la integración y coordinación de recursos y acciones. Lo novedoso de estos Consejos era que no se integraba solo con representantes del sector salud, sino con todos aquellos actores sociales de la comunidad que podían contribuir al bienestar y la calidad de vida. Esta estructura representaba el verdadero concepto del sistema local de salud que habíamos desarrollado en la OPS como espacio de planificación y concertación intersectorial, que años después la misma OPS consolidaba con el movimiento de los Municipios Saludables para la instrumentación de la estrategia de Promoción de la Salud, acorde también con el modelo de Ciudades Sanas de la OMS.

El programa se ponía en marcha a través de un convenio entre el Ministerio y los municipios, y en el tiempo que transcurrió hasta el fin de la gestión del gobierno de Cafiero, se firmaron más de 70 convenios con municipios de todo el territorio provincial, de los cuales llegaron a funcionar efectivamente en alrededor de 20 distritos. En todas las Regiones Sanitarias se

realizaron **Talleres de planificación estratégica participativa**, con representantes de la comunidad y profesionales de los distintos municipios, que tenían el objetivo de brindar a cada distrito las herramientas de planificación para el desarrollo de planes de salud locales con participación comunitaria. Cabe destacar que a pesar de la discontinuidad de esta política provincial con el cambio de la gestión del gobierno a fines de 1991, los Consejos Municipales de Salud continuaron funcionando en varios municipios.



***El Pro-Salud y el cólera:** No puedo dejar aquí de realizar un reconocimiento al primer Ministro de la gestión del Gobernador Eduardo Duhalde, Dr. José Pampuro, quién me confirmó en el cargo como Director Provincial de Planificación, y pude intentar mantener algunas de las políticas y programas de la gestión anterior. Tal como ocurrió este año con la pandemia de coronavirus, en el mes de enero de 1992, o sea a menos de un mes del comienzo del nuevo gobierno aparece en Perú la epidemia de cólera, que obligó al Ministerio, a todos los Intendentes Municipales y a toda la comunidad, en particular de los barrios populares del conurbano bonaerense, a realizar un programa de prevención con una gran movilización social para promover en la comunidad los hábitos de higiene y potabilización del agua con las “dos gotitas de lavandina”. Ante ciertas iniciativas del Ministerio que eran resistidas por los Intendentes por considerarlas invasivas a sus territorios, al mismo tiempo que estaban constituyendo “comités de cólera”, aconsejé al Ministro que convocara a los municipios a poner en marcha los Consejos Municipales de Salud para intervenir prioritariamente en la situación de emergencia, pero con la propuesta de continuar luego con el resto de las problemáticas de salud. Al Dr. Pampuro le interesó la propuesta, ya que estaba recibiendo las quejas de los Intendentes, y entonces me pidió si lo podía acompañar a presentarla ante el Gobernador y todos los Intendentes del conurbano, en el teatro Roma de Avellaneda. Así, se volvieron a poner en marcha muchos Consejos Municipales de Salud, y a pesar de un contexto político totalmente diferente, pudimos continuar con los Talleres de Planificación Participativa y el Pro-Salud hasta fin de ese año. En diciembre de 1992, el Gobernador nom-*

bra nuevo Ministro, quién esta vez me acepta la renuncia y termino mi gestión luego de cinco años como funcionario político, regresando a mi cargo de carrera profesional. De todos modos, al año siguiente tuve la oportunidad de realizar una nueva consultoría en la OPS, para realizar un programa de educación para los SILOS, que pude llevar a cabo en los años siguientes desde la Universidad.



Como médico sanitarista, siempre me inspiró la frase de Rudolf Virchow, que en el siglo XIX dijo que *“la política es medicina en gran escala”*, o la frase de Ramón Carrillo que decía que *“la mejor política de salud es un buen salario”*. La oportunidad de participar en una gestión de gobierno que me permitió transferir a la acción política la doctrina sanitaria de Carrillo, mi ideología en favor de la justicia social y la democracia participativa, fue una experiencia extraordinaria que colmó mis expectativas políticas y sanitarias. Más de treinta años después me siento muy orgulloso de haber participado en la que considero la mejor gestión política provincial en democracia, el gobierno de Antonio Francisco Cafiero.

La salud como producto social

He querido encabezar este relato con la definición de salud de mi maestro Floreal Ferrara, no solo porque considero que es la que mejor expresa la visión actual del concepto de salud, sino porque es la que refleja la realidad de una vida profesional, y seguramente toda vida personal. Ferrara es quizás la primera voz crítica a la definición de la OMS, cuestionando su carácter estático, y sobre todo su equiparación a la idea de adaptación, tanto en el campo físico, como mental y social. Define en cambio a la salud como un fenómeno dinámico en la búsqueda del óptimo vital, que surge del accionar permanente del ser humano frente a los conflictos que se le presentan en los tres campos mencionados. *“El hombre estará en salud si puede mantener ese intercambio, resolver los conflictos que se le plantean”*, dice Ferrara, por lo que el hombre enfermo es aquel que no logra resolverlos, tanto en el campo biológico, como el mental o social. El gran aporte de este concepto es la incorporación del hombre como protagonista principal del

fenómeno de salud-enfermedad, pero no solo en lo individual, sino también en el hecho social que determina su condición de bienestar y mayor o menor vulnerabilidad a la enfermedad. Esta posición de Ferrara es anterior a todo el desarrollo de la teoría de la medicina social latinoamericana, de la *“salud como proceso social”* de Asa Laurell, expresada luego por Pedro Luis Castellanos, Edmundo Granda y Jaime Breilh en el modelo de determinación social de la salud a partir de los modos, condiciones y estilos de vida de la sociedad, los grupos y las personas.

Desde el comienzo de la Cátedra de *“Salud, Medicina y Sociedad”*, hemos utilizado la definición de salud de Ferrara como el punto de partida de una concepción integral de la salud comunitaria, aplicable no solo a nivel individual, sino también a la salud colectiva. En un trabajo realizado con otros compañeros latinoamericanos, publicado por OPS en 1993, nos atrevimos a realizar una versión ampliada de esa definición, pero manteniendo la idea central: *“La salud, individual y colectiva, es el resultado de la relación dinámica entre los procesos biológicos, ecológicos, culturales y económico-sociales que se dan en una sociedad como producto del accionar del hombre frente a los conflictos que le genera su entorno natural y social”* (OPS, 1993). Se trataba que apareciera con mayor claridad la idea de la acción del hombre no solo en lo individual, sino en la responsabilidad sobre la salud colectiva. Lo social no es una categoría abstracta solamente descriptiva, de la que nadie tiene responsabilidad como en el hecho biológico, sino que responde a modelos, sistemas y determinaciones sociales producto de las decisiones de actores sociales y políticos que influyen sobre la vida de los pueblos.

A principios de los noventa tuve la oportunidad de volver a trabajar en OPS con mi amigo colombiano Gustavo De Roux, quién siendo Ministro de Salud de Colombia, organizó en 1992 una de las primeras reuniones de América Latina sobre *“Promoción de la salud y equidad”*, de la cual surgió la *“Declaración de Santa Fé de Bogotá”* que trató de adecuar la propuesta de promoción de la salud de la Carta de Otawa (1986) a la realidad latinoamericana. En ese documento aparece por primera vez el concepto de *“la salud como producto social”*, como expre-

sión del reconocimiento de la responsabilidad política de los gobiernos y todos los grupos y personas con recursos de poder, respecto de la situación de salud de la población. Con la idea de una mejor comprensión de este concepto, y como una evolución de la concepción original de Ferrara, enriquecida con aquella definición del grupo de OPS, en el documento de 1993 hice mi aporte personal con la siguiente definición, que desde entonces también enseñamos en la Cátedra: *“La salud es un producto social, porque es la resultante de las acciones, a favor o en contra, por acción u omisión, que realizan los distintos actores sociales y políticos que intervienen sobre las condiciones de vida de las poblaciones”*. (Pracilio, 1995). No hay proceso de salud-enfermedad-atención al que no se aplique esta definición, desde las enfermedades de la pobreza hasta las producidas por la degradación ambiental, producto de la acción u omisión de los responsables políticos y del modelo económico de mercado, que también tienen nombre y apellido a nivel internacional, nacional o local. Desde el cambio climático hasta la pandemia que estamos viviendo en el mundo sabemos que es producto de la acción depredadora del hombre sobre la naturaleza, como lo expresa claramente el Papa Francisco en la Encíclica “Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común”.

Para concluir, la pandemia...!

En un par de años cumpliré cincuenta como médico, y llevo más de cuarenta como sanitarista y docente de Salud Pública. Nunca me hubiera imaginado vivir la situación de una pandemia, ahora ya no como funcionario o profesional sanitario, pero sí como docente y como persona del grupo de riesgo. Tampoco hubiera pensado ver a los medios de comunicación saturados de Epidemiología, difundiendo diariamente los casos y muertos por una sola patología, cuando desde la salud pública no hemos logrado aún concientizar a la sociedad y a los decisores políticos sobre la tragedia de miles de muertes anuales por infartos, ACV, accidentes y otras enfermedades transmisibles, muchas de ellas prevenibles.

Por mi formación sanitaria y epidemiológica, me genera un cierto grado de preocupación la respuesta del sistema de salud a la pandemia,

como si la epidemiología y prevención del coronavirus fuera diferente a la de las otras patologías transmisibles, y que la única alternativa de control desde los servicios de salud fuera la provisión de UTI y respiradores, cuyos resultados son aún inciertos. Por el contrario, la realidad está demostrando que las estrategias de promoción y de protección de la salud son las más efectivas, como el aislamiento físico, el lavado de manos, la higiene de las superficies, la protección adecuada, etc. Reconociendo la gran contagiosidad de esta enfermedad, que jaquea todas las conductas sociales habituales, el gran desafío continúa siendo que es mejor prevenir que curar, incluso para evitar la saturación del sistema asistencial. La sociedad ha descubierto que la cuarentena, medida de salud pública de la Edad Media, parece ser el mejor remedio contra la enfermedad. Pero en realidad la verdadera prevención se encuentra en las medidas de higiene personal enseñadas por Hipócrates a sus discípulos hace 2500 años, y Galeno en la Roma del siglo II.-

En efecto, toda la información científica actual confirma que la lucha contra el coronavirus sigue siendo el cuidado de la salud, que comienza con el autocuidado (individual, familiar y comunitario), y debe seguir por los servicios de salud del primer nivel de atención. Por lo tanto, los que hemos creído y defendido durante años la estrategia de atención primaria de la salud, o como prefiero denominarla, de Cuidado Primordial de la Salud (Health Primary Care), no podemos tirar por la borda todo lo declamado y volver a privilegiar el modelo hospitalo-céntrico en la lucha sanitaria contra la pandemia. Precisamente, de la eficacia del cuidado primordial de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, dependerá el mayor o menor uso de los hospitales, de las UCI y de los respiradores.

Al escribir estas líneas sobre mis afanes por la salud comunitaria en tiempos de pandemia, no puedo menos que ratificar el concepto de salud de Ferrara como *“la lucha del hombre frente a los conflictos”*, que no son solo biológicos, sino también psicológicos y sociales. O de la salud como “producto social”, porque más allá de sus causas biológicas o ambientales, el resultado final en términos de salud y mortalidad está dependiendo también de las decisiones de los

gobiernos y de los ciudadanos. Seguramente cuando se conozca finalmente en esta pandemia la distribución de la mortalidad por clase social y por etnia en todos los países, mostrará lo que viene denunciando la medicina social latinoamericana sobre la determinación social de la salud, tanto en el origen como en la respuesta social ante la enfermedad.

Finalmente, ante la pandemia cabe recordar también lo que Ramón Carrillo ya decía en todos sus discursos, que son los factores sociales y económicos los que determinan la salud de las personas, ya que no hay hospitales ni respiradores que alcancen, cuando la desigualdad en las condiciones de vida y el acceso a los sistemas de salud definen quién se enferma y quién se muere. Por eso cobra hoy más sentido su conocida sentencia: *“Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”*.

Si en esta tercera guerra mundial que nos ha declarado el coronavirus, la batalla final de esta inesperada contienda, en lugar de darla en la comunidad, en los hogares de ancianos, en los barrios carenciados, debemos librarla en los hospitales, habremos perdido la guerra, como ya la perdieron en otros lugares del mundo.

***Prof. Dr. Horacio Pracilio**

Médico sanitarista. Ha sido Profesor de Salud y Medicina Comunitaria y Director de la Maestría en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, y Jefe del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Entre 1987 y 1992 fue Director General de Planificación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Antonio Cafiero en representación de la UNICEN.

EL ENCUENTRO CON UN NIÑO SANO, NO SIN CONFLICTOS



DR. FERNANDO ALONSO*

La infancia no es un paraíso

Aunque parezca paradójico, más allá que un niño o niña atravesase su infancia con cierta armonía y sin tropiezos, algunos síntomas se harán presentes en este tiempo. En algún momento de su vida cierta perturbación aparecerá y provocará malestar en la familia o en el mismo niño. Esta situación, posiblemente, genere una consulta al pediatra: que el hijo “come poco”, que “llora a toda hora”, que “muerde a la madre”, que “qué no acepta límites”, que “no duerme en su cuna”, que “hace berrinches por cualquier cosa”, que “rompe los juguetes”, etc.

Si todo anda más o menos bien, es de esperar que un hijo conmocione a sus padres, rompa los esquemas esperados con sus comportamientos fuera de lugar y tenga algunas conductas o manifestaciones imprevistas. Muchas veces estas características conflictivas hacen que los padres consultan al pediatra, transformándolas en síntomas: irritabilidad (“solo se calma con la teta”), problemas del sueño (“no duerme en toda la noche”), dolores abdominales (“tiene cólicos”), inapetencia (“rechaza la comida”), agresividad (“les pega a otros niños”), etc.

El ideal de familia se cumple generalmente cuando nace un hijo, pero todo parece derrumbarse cuando los adultos no pueden manejarlo o no entienden su comportamiento. “Nunca pensé que criar un hijo era tan complicado” repiten una y otra vez las madres y los padres que visitan al pediatra en sus consultas de rutina. Pero ¿qué lugar darle a esta problemática en un niño saludable?, ¿qué responsabilidad le cabe a la familia y cuánto le concierne al hijo?, ¿cuándo

debemos alertarnos y sospechar que hay una dificultad que es necesario explorar?, ¿qué tipo de intervenciones es recomendable?, ¿cómo diferenciar estos síntomas esperables de los fenómenos clínicos que indican patología?

En primer lugar, el médico que atiende niños debe evaluar el desarrollo psicomotor, pero además es necesario que pueda precisar en qué momento de la construcción de su identidad se halla el pequeño paciente. Es indispensable situar el modo de lazo social que despliega, su relación con el límite a la satisfacción y detectar si la estructuración psíquica está detenida, perturbada, obstaculizada, o si tan solo tiene un particular devenir, con manifestaciones clínicas que solo muestran los altibajos esperables de un niño sano en una familia relativamente armónica.

Además, si bien al que traen a consulta es al niño, no significa que éste sea siempre el que presenta el problema original. Si exploramos detalladamente la dinámica familiar, aunque en un primer momento resulte equilibrada y funcional, y escuchamos a los integrantes de la familia con atención, puede suceder que el conflicto esté disimulado, y en realidad le corresponda a cualquiera de los adultos que lo trae a la consulta, o a su grupo familiar, o a la escuela que lo deriva, o a un contexto social desfavorable.

¿Por qué consultan?

Tal como lo indica Lacan en Dos notas sobre el niño en 1988, el síntoma del niño puede representar una verdad oculta de un malestar en la familia (ej. cuando un hijo está en el centro de la

atención de la pareja parental y es lo único que los une). Por eso hay que estar atentos a cada padre en forma individual, la posición del niño en la historia familiar, el deseo y expectativas de padres y abuelos, la conformación de la estructura familiar actual y fundamentalmente el vínculo entre ellos.

En primer lugar, puede suceder que la consulta puede ser bien definida, “mi hijo no duerme de noche” o “hace berrinches todo el tiempo”. Sin embargo, algunas veces la demanda es imprecisa, la preocupación real está solapada por consultas reiteradas innecesarias por una supuesta patología. Por ejemplo “no come lo suficiente, aunque el peso es normal”, o múltiples llamados telefónicos que al profesional le resuenan innecesarios y banales. Por lo general, este tipo de consulta esconde una preocupación inconsciente sobre las dificultades de relacionarse con su pequeño hijo o, como decíamos anteriormente, el problema está en otro lado.

En algunas ocasiones los padres buscan saber algo. Les hace falta información y le preguntan al pediatra por qué su hijo presenta determinado síntoma: “mi hijo me desafía” o “está prendido a la teta día y noche”, etc. Este tipo de consulta le da un lugar al diálogo, facilita un intercambio entre el profesional y los padres, lo que permite que estos se interroguen por su responsabilidad en el síntoma de su hijo, resultando muchas veces productivas las intervenciones del pediatra orientando a los padres en los avatares de la crianza.

En otras oportunidades los padres acuden al médico sólo en busca de alivio, no se preguntan nada. Van en búsqueda de la receta de cómo encontrar la complementariedad exacta entre ellos y el hijo, pretenden que el pediatra, en un abrir y cerrar de ojos, les devuelva el hijo obediente e ideal que ellos desearon siempre. Con frecuencia escuchamos que le dicen al hijo “oíste lo que dijo el doctor, si te portas mal él se va a enojar”, depositando en el otro la responsabilidad de poner límites, que les corresponde a ellos. En estos casos, es recomendable desmitificar la idea de que “las relaciones humanas ideales son posibles”, introducir el concepto de que la niñez es una etapa complicada, atestada de obstáculos y que ellos puedan aceptar que su hijo no siempre cumplirá rigurosamente sus expectativas. Además, tenemos que aclararles que no es perjudicial que como padres pongan

límites claros, aunque generen pequeñas frustraciones, ya que, estas experiencias irritantes ahora, serán beneficiosas a la larga.

Por último, hay padres que no se preguntan nada ni quieren que le cambien al hijo, sólo consultan porque los mandó alguien: la abuela, la tía, la maestra del maternal, etc. En este caso, la demanda surge desde afuera de la familia nuclear y generalmente, aunque asisten al pediatra, están molestos ya que la visita al médico viene a interrumpir un modo de disfrute inconsciente (ej. “el niño duerme en la cama de los padres” o “solo come si lo alimenta la madre”). Ellos consultan para cumplir con un mandato (“la abuela está preocupada”), y juzgan al que los alertó como exagerado y desmedido. Estos son casos muy difíciles donde los padres están muy cerrados a las intervenciones, con las cuales habrá que ser cuidadosos para no provocar la expulsión del paciente y poder, más adelante, ir concientizándolos de las dificultades encontradas cuando éstas sean más evidentes. En estos casos, debemos aceptar que el que los mandó tiene influencia y autoridad sobre los padres, y será esta la palanca en la que podemos apoyarnos hasta lograr crear cierta empatía y confianza con ellos para iniciar nuestras intervenciones.

Atentos al niño

Cuando el pediatra recibe en el consultorio a los padres de un recién nacido o un niño que todavía no habla, por lo general éste se encuentra en brazos de la madre y el intercambio se plantea simultáneamente con la mamá y el bebé. Aquí el pediatra interviene facilitando la construcción corporal del bebé y la regulación de las funciones normales, aclarando a los padres algunas de las reacciones físicas que tiene su hijo (llantos, respiración irregular, reflejos, entre otras) y estimulando la transmisión de ritmos y hábitos (alimentación, sueño, estímulos y juegos, etc.), respetando las reacciones del niño acordes con las actitudes emocionales de la madre, en relación con sus dichos e interpretaciones.

Se destaca a los padres que su hijo, al que es conveniente dirigirse por su nombre, es único e irrepetible y que la crianza de éste debe tener la marca de sus decisiones. Se les advierte que es admisible oír los consejos de familiares y amigos experimentados, pero que serán ellos mismos, en la intimidad con su hijo, quienes resuelvan

cuándo alimentarlo o arrojarlo y cuando consideren que algo anda mal, en qué momento deban consultar al médico.

Este es un momento muy enriquecedor y se debe estimular la díada entre madre e hijo. En este tiempo inicial el niño ingresa en un espacio no accesible directamente al sentido común, donde los sonidos, la mirada, el tacto cobran un valor de inscripción. Esta red de sensaciones, placenteras y displacenteras, hacen tensión con la función inmadura del organismo y se orientan a partir del deseo materno y sus interpretaciones de lo que su hijo requiere. Sin embargo, esta recepción materna (el Otro primordial), apoyada por el lenguaje, debe dar paso pronto a una separación que permita que ese niño encuentre su singularidad a partir de su propio deseo y pueda construir una identidad: así el niño podrá dirigirse hacia otros (el Otro social), más allá de su madre o de su familia, y relacionarse con los demás con una herramienta fundamental, la palabra.

Cuando la consulta es por un niño que ya deambula y dice algunas palabras, vemos que algunos son muy tímidos, se abrazan a su madre y no hablan o hablan en voz muy baja, mientras que otros se comunican con facilidad. El niño en esta etapa se encuentra bregando por la separación de su Otro primordial y los síntomas más frecuentes son la angustia y la culpa que esto le genera (“¿Por qué dormís todavía con tu mamá? Le pregunto a una niña de 4 años, y me responde “porque ella no puede dormir sola todavía”). Es un tiempo de destete, con todas las consonancias metafóricas que esto implica. Es un tiempo donde el niño comienza a dejar de ser el hijo de mamá, para encontrar su lugar entre los demás, otros niños como él y otros adultos como sus padres.

En esta edad, el niño habla y está atento a lo que se dice, aunque a veces no lo parezca. Es recomendable dialogar con el niño, nunca dejarlo de lado en la conversación que se mantiene con sus padres. Explicarle quién es uno, en qué consta su trabajo, mostrarle los lugares de los consultorios dedicados para revisarlo y los espacios que tiene para jugar, etc. Es muy enriquecedor mientras uno habla con la madre y el padre, mirar de “rejo” lo que el niño hace, observar sus gestos, sus actitudes en relación con lo que expresa o dice su madre, a que juega y como juega cuando él supone que no se lo está observando.

Es habitual que los padres hablen delante del niño presumiendo que él no está presente (“no estamos por separar, pero él todavía no lo sabe”). El pediatra tiene que comunicarles que su hijo escucha y que muchas veces, cuando está jugando y parecen distraídos, es uno de los momentos donde los niños tienen toda la atención puesta en la conversación de los adultos.

Resulta muy valioso, tanto para un diagnóstico como algunas intervenciones, en ciertas oportunidades, dejar de lado la conversación con los padres y dedicarse de lleno al niño. Si habla, dialogar con él, escuchar lo que tiene para decir, preguntarle por qué vino a vernos e interesarse por su hipótesis del problema, pero también por sus intereses y explorar los relatos de sus vivencias. Si no desea hablar o no sabe, dejarlo jugar o dibujar, tomar nota de su accionar, incluirse de algún modo en su mundo, sin pretensiones. Guardar silencio, jugar o dibujar junto a él (el juego y el dibujo son modos de expresión con las que el niño está más familiarizado), intercambiar preguntas sobre lo que está haciendo permitirá entablar una comunicación con el pequeño paciente, pero fundamentalmente permitirá conocer al niño en su condición de sujeto singular.

Los síntomas como problema del niño pequeño

A veces, los padres traen a la consulta a un niño o niña como interrogante porque algún síntoma les provoca preocupación. La inquietud por una conducta problemática del hijo puede ser simplemente el anuncio de que está atravesando etapas del desarrollo esperable para su edad, tal como el “llanto del tercer mes”, “la angustia del octavo mes” o los “berrinches a los dos años”. Sin embargo, en muchas oportunidades el pediatra se enfrentará con síntomas que le señalan un malestar en la familia y un sufrimiento en el niño sobre el que es conveniente intervenir: “rechazo del alimento”, “berrinches excesivos”, “oposicionismo inflexible”, “no habla todavía”, entre otros.

Estas conductas que preocupan a los padres tanto como al médico, son fenómenos clínicos que nos sorprenden, que son imprevistos y de alguna manera creados por el niño, por eso los llamamos síntomas. Sin embargo, no siempre indican enfermedad, esta manifestación pertur-

badora, tal como lo conceptualiza el psicoanálisis, es sólo una señal, una alarma, un llamado al otro. Lo que hace al síntoma patológico, no es el síntoma en sí mismo, sino el uso que el niño hace de ese síntoma (Tizio, 2011). Algunas veces se trata de una molestia que solo indica que el infante está creciendo, enfrentándose a nuevas formas de ser y de relacionarse con un cuerpo cambiante que no comprende bien (“camina y toca todo, come pero tira la comida al suelo, juega con otros niños pero pega”), otras veces es solo un llamado de atención (“se porta mal solo con la madre”), en otras oportunidades es un modo desmedido de lograr satisfacción (“se chupa el dedo todo el día”). Pero es importante tener en cuenta que en algunas circunstancias el síntoma señala un sufrimiento mayor originado en dificultades que necesitan ser indagadas y tratadas (ej. la desconexión en el niño autista o retracción en un niño maltratado).

El médico puede atender pacientes que tienen un desarrollo madurativo esperable para la edad y muy inteligentes, pero con un modo primitivo de lazo con su madre (“es líder en el jardín, pero duerme en mi cama”, dice una madre) y una forma de disfrutar su cuerpo compatible con las edades más tempranas (“tiene 3 años y sólo se alimenta con mamadera”).

Es necesario estar atentos a aquellos niños que, durante el camino de la estructuración psíquica, tienen un tropiezo, un obstáculo insuperable, un bloqueo que los esté estancando. Observar cómo se relaciona, como percibe su cuerpo y de qué forma lo maneja, qué tipo de juego despliega, qué le provoca satisfacción y qué rechazo o miedo, cuál es su deseo y qué hace con él, son datos semiológicos fundamentales para ubicar si tiene o no problemas graves con la estructuración psíquica y la construcción de su personalidad.

El infante está en constante crisis potencial en virtud de su estado de dependencia del adulto, se halla muchas veces en un equilibrio psicossomático siempre renovable, que pivotea y que hace muy difícil localizar los bordes de la “normalidad”. De este modo, entendemos que cierta “anormalidad” forma parte de los tiempos de la infancia y que solo será preocupante cuando se hace crónica o cuando recae en profundos excesos. Será ese el momento en que el pediatra utilice la herramienta de la derivación a un especialista que profundice la búsqueda para detener el

sufrimiento de este niño y su familia.

El pediatra que atiende lactantes y niños pequeños debe estar atento a las señales somato-psíquicas del paciente que está en un tiempo donde lo físico y lo mental se hace indiscernible. Los niños pequeños se expresan con el cuerpo, con sus conductas y sus movimientos. Tanto los cambios precedentes de su cuerpo como los surgidos por su entorno provocarán rupturas y tropiezos en el transcurrir de desarrollo.

NO HAY RELACIONES IDEALES ENTRE PADRES E HIJOS

Por más que el hijo haya sido deseado y sea muy querido por la familia, nunca va a encajar plenamente con las expectativas de sus padres. De ningún modo un hijo podrá ajustarse de manera completa a lo que la madre y el padre habían pensado de antemano, dado que habrá un desfase irreductible entre la ilusión del hijo pensado y el niño que ha nacido y sus impredecibles respuestas. El niño irá encontrando sus gustos, su manera de ser, formas de disfrutar la vida que está desligada de todo sentido y de consideración lógica. Esto marca la diferencia entre el hijo y sus padres, permitiéndole transitar su devenir subjetivo, por fuera de la fantasía de quienes lo engendraron o lo adoptaron. Por eso, un hijo siempre introducirá en la familia algo impensado, singular y desconocido, y esto irá anunciando su marca particular. Si todo transcurre bien, la relación entre el niño y el otro se incomodará, o sea, el niño no logrará una satisfacción completa y sus padres no tendrán todas las respuestas. Entre ellos habrá un desencaje “perfecto”.

De la tolerancia, la flexibilidad y el acomodamiento, tanto consciente como inconsciente que hagan sus padres para sobrellevar la perturbación que les provocará este desacople, y de la aceptación del niño de que no se posible una satisfacción sin límites, dependerá la continuidad del transcurrir del niño hacia el encuentro de su lugar en el mundo. “Pensábamos que íbamos a disfrutar de tener un hijo, pero nos deja agotados y por momentos desconcertados” confiesan (o se infiere de la entrevista) los padres de pequeños pacientes en la consulta pediátrica de control sano.

El síntoma de la infancia lleva la marca del padre y de la madre que ese niño ha tenido, pero

esto no ubica como causantes a los padres de lo que le sucede al niño, sino que nos hace interrogar sobre qué lugar ocupan para él cada uno de ellos. El niño no está predeterminado por sus marcas, sino que solo va a tener que darse mañas con ellas. La manera que encuentre para arreglárselas con las huellas que dejaron sus primeras vivencias y con las herramientas que trae de fábrica construirá su modo particular de ser, así como sus satisfacciones y sus disgustos.

Si el niño sigue camino hacia la individuación, dejando de ser solo el hijo deseado por sus padres para ser un niño singular y con deseo propio, se ubicará por fuera de lo que sus padres pretendieron y pretenden de él y para él. Esto podrá suceder en tanto la madre y el padre que lo desearon, que lo esperaron y lo recibieron, estén dispuestos a tolerar ese desfasaje, esta “desilusión”. El hijo desea otra cosa que sus padres. De esta manera, el niño que no “encastra” con ellos, “hará juego” en los engranajes del marco de su existencia y provocará chirridos en el transcurso de la infancia, y eso muchas veces es visto como síntomas.

Estos síntomas cumplen una función, implican un llamado, son ricos en sentido. Es por ello por lo que, a diferencia la mirada médica estricta, cuando aparece un síntoma en el plano psicológico lo mejor no es eliminarlo, sino ponerlo sobre la mesa y explorarlo, entender que algo pasa con ese niño y su familia que tenemos que tratar de comprender y de algún modo modificar, para que ese síntoma desaparezca o, si no puede, se regule, y ya no sea un malestar (“ahora lo dejamos pasar a nuestra cama, pero solo los domingos y cuando hay tormenta”).

Será entonces tarea del pediatra detectar encajes y desencajes en las relaciones familiares, así como tener lo mas en claro posible porqué traen al niño a la consulta y dónde se origina el fastidio familiar. El síntoma solo puede anunciar que el niño va marcando su paso en un camino que él no planeó, y esto resulta un enigma para los otros (rabietas), o se trata de una señal que está velando algún desacople familiar (angustia de separación) o, si el problema mayor, nos anuncia un severo compromiso de la constitución psíquica (autismo).

NO HAY INFANCIA SIN SÍNTOMAS

La niñez, al contrario de lo que se sostiene con

frecuencia, no es siempre un tiempo alegre y tranquilo al que todos ambicionaríamos volver. Por eso, a través de la represión, los adultos olvidamos el agitado camino de los primeros años de la vida.

La infancia no es un camino de algodones, más bien es un sendero pedregoso que conlleva cierta limitación y privación de lo que ese niño quiere hacer. Los hijos son activos y se meten en líos, quieren cosas que no les podemos dar por peligrosas, o reclaman modos de satisfacción que no debemos ofrecer sin cierto límite. La familia primero y la escuela después serán los encargados de que el niño tenga pequeñas frustraciones (ej.: “todavía no te toca la teta”, “quédate sentado ahí”, “no toques eso”, “esperá, que ahora estoy con tu compañerito”).

Todo niño se enfrenta, en el transcurrir de los días con necesidades o demandas no satisfechas, tendrá que aceptarlo indefectiblemente por más que los padres se esmeren en resolver todo su reclamo. Qué esto le pase es bueno, por más que “a la abuela o a el tío no le guste”, será un tiempo donde elaborará algo fundante del aparato mental: el encuentro con la falta. Que exista la falta es algo favorable para la construcción del aparato psíquico. Que algo falte, hará que el niño tenga un deseo, así se pondrá en marcha en búsqueda de encontrar algo que suplante esa falta, entonces inventará, creará algo que de alguna manera irá marcando su vida, su existencia con sello propio.

Recuerdo una consulta que fue muy aleccionadora: una madre se queja ya que su hija de 18 meses no le permite baldear el patio tranquila, se le cuelga de la pollera, se patina, se cae y llora. Luego de hacerle una intervención, la madre hace un cambio: Un día la deja a su hija detrás de la puerta mosquitero, la chiquita la puede ver, pero no puede pasar. Lloro un rato, se queja, la madre la ignora, esta vez pudo estar absorta en su tarea, entonces la niña se sienta y se pone a jugar con unas ollas que encontró en el suelo. La hija descubrió en ese episodio que la madre no la satisface en todo y que a veces responde a sus llamados y otras no, y que cuando lo hace, lo hace en mejor o peor tino. Eso es bueno para ella (y para la madre). La niña encuentra un espacio libre y pone en marcha sus herramientas simbólicas, el espacio transicional que Winnicott describió en 1994, una zona intermedia de experiencia donde podrá desplegar su capa-

cidad creadora y su imaginación y le permitirá introducirse en el orden de la humanización y el encuentro con su identidad. Al mismo tiempo, la madre ya no es madre solo madre, recupera su lugar de mujer, reencontrándose con ella misma, algo tan importante como el desarrollo de su hijo.

El encuentro con el “no todo” es un momento necesario y doloroso: El niño descubre que todo no se puede (así como tampoco su madre puede todo), es así que tiene que aceptar con resignación que hay límites que son esenciales para para vivir en sociedad. Esta mezcla de dependencia e impotencia provocan una crisis existencial en el niño y también colocan en tensión a los padres. Son tiempos de poner a raya todo impulso, donde los padres se presentan como agentes de frustración, pero no cabe duda de que son fundamentales para la estructuración psíquica, aportándole herramientas que el pequeño usará en la construcción de su identidad y su inserción social y cultural.

Conclusión

La infancia es un extraordinario tiempo de inicio del ser humano, que por momentos se pone tormentoso para quien la transcurre. La sociedad actual no ayuda a alivianar este complicado lapso: los límites no están claros, no hay orientación para los niños, los adultos ofrecemos a nuestros hijos pocos mojones que hagan predecible la existencia, los ideales se diluyen, la autoridad no funciona bien. Hay un empuje desenfrenado a que todos es posible como lo podemos percibir en la propaganda de una reconocida marca deportiva que propone *Impossible is nothing. Just do it* (Nada es imposible. Solo hazlo).

Las familias actuales han perdido el formato tradicional, están conformadas de múltiples maneras. Ya no se habla de familia dada a la dificultad de clasificarlas, hablamos de “parentalidad” (Laurent, 2018) y hay nuevos modos de relaciones sociales. El niño de hoy nace en un mundo líquido (Bauman, 2017) donde las fronteras se mueven o no existen y en este universo impredecible, a los adultos no nos es fácil transmitir a los niños ese freno humanizador, esas riendas que le permitan regular y sofrenar los impulsos tan típicos de la niñez temprana.

Para colmo, si el niño se sale de las nomas, si

no responde como pretendemos, la solución más rápida propuesta por la sociedad contemporánea y parte de la ciencia, es nombrarlo como un “trastorno”. Debemos estar muy alertas y advertidos sobre las consecuencias de interpretar los sentimientos humanos en el sentido de la enfermedad, esto es, la patologización de la infancia. Es el lado tranquilizador de una visión mecanicista del ser humano. Estos tipos de enfoques, muchas veces, tienen como única pretensión eclipsar del niño, vía rienda farmacológica o con técnicas de reeducación, con la pretensión de una inmediata adaptación y ajuste a lo que de él se pretende. Se reduce, en algunos casos, la subjetividad a un conjunto de conductas provocadas por una cadena de neuronas y de neurotransmisores donde el niño-persona se anula, se invisibiliza. Y entonces poco o nada importa la singularidad del padecimiento, ya que la receta a aplicar son protocolos, es decir, es siempre la misma e igual para todos.

Se requiere de una visión amplia. El planteo, tanto en cuanto a la escucha e intervenciones, como en cuanto a una posición personal y profesional, es tener el mayor conocimiento posible, tratando de utilizar multiplicidad de conceptos y sus mejores abordajes, apoderándose de ellos para transformarlos en herramientas prácticas, y darle un buen uso. Esto propiciará mejores condiciones para respaldar la travesía singular del encuentro con un niño en cada una de las situaciones que se presentan. No hay duda de que es tentador acallar, borrar y poner debajo de la alfombra lo que molesta, “para que incomode lo menos posible” y que preguntarse sobre lo que el niño desea, o cómo funciona la familia, puede provocar una incómoda polvareda.

En el inicio de la infancia el niño o la niña descubrirá que no todo es posible, y esto tendrá consecuencias, de cuyas variantes, en este juego de pérdidas y ganancias dependerá su existencia, y bien sabemos que no es lo mismo vivir que existir. En el marco de lo expuesto, propongo acompañar como médicos los primeros años de la niñez teniendo en cuenta que existen problemas que generan sufrimiento y requieren abordajes especializados, no obstante, los desórdenes en este tiempo son la norma, y muchos de los síntomas por lo que consultan al pediatra son solo las respuestas a esa dificultad original de cómo relacionarnos con el otro, típica del cachorro humano.

Bibliografía

-

Bauman, Zygmunt. *Reflexiones sobre un mundo líquido*. Ediciones Paidós, Barcelona, 2017.

Flesler, Alba. *El niño en análisis y las intervenciones del analista*. Paidós, CABA, 2011

Freud, S. - "Más allá del principio de placer", en O. C. T XVIII, *Amorrotu Ed.*, Bs. As., 1990

Lacan, J., "Dos notas sobre el niño", *Intervenciones y textos 2*, Manantial, Buenos Aires, 1988.

Laserre, Aníbal, *Una lectura de Nota sobre el niño* Grama ediciones, Buenos Aires, 2016

Laurent, Eric. *El niño hoy y la parentalidad contemporánea*, Conferencia en la Facultad de Psicología UBA. Buenos Aires, 18 de mayo del 2018

Schejerman Fabian. *Psicopatología: clínica y ética*. Grama ediciones, Buenos Aires, 2013.

Tizio, Hebe. *La función del síntoma*. Editorial Universidad de Granada, 2015

Winnicott, Donald. *Realidad y Juego*. Gedisa, Barcelona, 1971

*Dr. Fernando Alonso

Pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Psiquiatra Infanto Juvenil del Hospital Provincial de Rosario. Responsable de la Concurrencia de Paidopsiquiatría del Hospital Provincial de Rosario. Profesor Titular en la Carrera de Posgrado de Especialización en Pediatría de la Universidad Nacional de Rosario.

APORTES PARA UNA INVESTIGACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS, SUS FAMILIAS Y LAS REDES DE APOYO



DR. JORGE LUIS PEPE*

MG. BIOQ. LILIANA MINGILLO**

LIC. EN SALUD AMBIENTAL CLAUDIA ROCCA***

DRA. SILVIA MASINI****

La comprensión de los fenómenos que inciden en el crecimiento y desarrollo en el periodo materno infantil, como ejes fundamentales de la Pediatría Clínica, requiere un continuo proceso de análisis e investigación, que permitan una mayor comprensión de los mismos, para mejor abordaje de nuestras poblaciones.

El proceso de transición epidemiológica de salud infantil muestra un panorama complejo que resulta de la interacción entre los impactos positivos en materia de intervenciones sanitarias eficaces y el aumento de los problemas generados, entre otros, por el deterioro de las condiciones de vida. En este escenario dinámico se encuentra la mortalidad infantil que continúa su tendencia descendente (Lejarraga y col 2016). En la Argentina de 9,7 ‰, esta tasa no brinda información acerca de la condición de los 930 niños que sobreviven. (MSA, DEIS 2018). En muchos países en desarrollo, ocurre que aquellos niños que sobreviven no crecen ni se desarrollan adecuadamente. Estimaciones de expertos coinciden que, en ellos, más de 200 millones menores de 5 años no llegan a su potencial en el desarrollo cognitivo (Grantham Mc y col 2007)

Actualmente existe un consenso entre teóricos e intervencionistas que los aspectos individua-

les (genotipo) y las características socioeconómicas y culturales (fenotipo) contextualizadas por el medio ambiente, así como las tareas que se realizan en los diferentes contextos, son determinantes en el proceso de desarrollo. Este último supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos (ecológicos) en los que esa persona en desarrollo vive. Entornos de cuidados socioambientales, desde una perspectiva ecológica, pueden constituirse así en factores que, sumados a los biológicos, afecten el crecimiento y desarrollo (Bronfenbrenner 1979), (Myers 1993), (Hatt y Waters 2006), (Sales Nobre y col. 2009).

En la primera infancia los principales vínculos, así como los cuidados y los estímulos necesarios para el crecimiento y el desarrollo, son proporcionados por la familia. Los factores genéticos, la nutrición, la salud, el ámbito donde el niño crece y las oportunidades que le ofrece la familia son determinantes del desarrollo infantil (Lejarraga H 2008), (Bustos C, Herrera M, Mathiesen M 2001).

Las familias, siendo un sistema abierto que se desarrolla en el intercambio de relaciones con

otros sistemas, han sufrido transformaciones, las cuales reflejan cambios más generales de la sociedad (Stolkiner A 2004). De esa manera surgen nuevos arreglos, diferentes de la familia nuclear anteriormente dominante, constituida por el matrimonio e hijos. Cualquiera que sea su estructura, la familia se mantiene como el medio relacional básico para las relaciones del niño con el mundo. La teoría ecología del desarrollo humano, subraya la complejidad de las interrelaciones en el ambiente inmediato. Depende de la existencia y naturaleza de las interconexiones con otros ambientes complementarios, permitiendo contextualizar los fenómenos del desarrollo en los varios niveles del mundo social.

La interrelación e interacción de esas fuerzas originadas en los subsistemas generan un sistema de red social. El concepto de red social implica un proceso de construcción permanente tanto individual como colectiva, en un sistema abierto que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita la potencialización de los recursos que poseen. Cada miembro de una familia, grupo, o institución, se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla (Dabas E 2001).

Por lo tanto, la familia es considerada por distintos autores, como la primera red de apoyo, es la proveedora de cuidados a través de su propio “sistema de cuidados cotidianos”, que es dinámico y original de cada una, desarrollado de acuerdo a sus propias potencialidades y limitaciones pero que responde a sus características socioculturales. Se sostiene que cada miembro va generando su propia red que tiene un nivel de autonomía que le permite interactuar en determinado momento con algunos elementos de la red de apoyo familiar (red doméstica) y social. De allí el valor que la familia tiene en el desarrollo de la comunidad. Ella es el único ámbito donde se genera la vida e inicia el individuo su crecimiento y desarrollo multidimensional cuya interacción posibilita la vida y la salud, por ende, le permite integrarse a la malla social mediata (redes informal y formal). (Dabas E 2001), (Bronfenbrenner U 1996)

Las redes informales (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de actividades recreativas) y redes formales (instituciones y organizaciones de la comunidad) en una vecindad amplia las miradas sociales y también académicas

que restringen las prácticas de crianza y el desarrollo de los niños y niñas al ámbito de la familia nuclear (bajo el modelo occidental) (Santillán L 2010). Disponer de estas redes sociales le da a la familia mayores posibilidades de funcionalidad y recursos para atender su cotidianidad. Su aislamiento social la hace vulnerable, muchas de sus necesidades básicas no pueden ser satisfechas al estar limitadas las posibilidades de interaccionar con la red de apoyo (Dabas E 2015).

El significado e importancia del apoyo social varían a través del ciclo de vida, y tiene diferentes funciones en los distintos periodos de la vida de las personas (Cohen S, Syme L 1986). El apoyo social induce elevación de la autoestima y habilidad de afrontamiento. Un modelo predictivo adecuado de las relaciones entre el apoyo social y el bienestar, debe considerar las diferencias individuales en la necesidad o deseo de apoyo social, así como los contextos sociales y ambientales en los cuales el apoyo social es percibido, movilizado, proporcionado y tomado.

Contribuciones de investigaciones sobre el tema

Las investigaciones desde las diversas disciplinas que conforman el objeto de estudio presentan desarrollo amplios y profundos (tal es el caso de las investigaciones sobre patologías secuelas neonatales, los enfoques de la epidemiología ambiental y social, etc. (Torralva T y col 1999), (Mathiesen M y col 2001), (Vasconib T y col 2013), (Pepe J y col 2015).

Sin embargo, los estudios que integran estas dimensiones con la perspectiva de la salud familiar y comunitaria, y con una introducción decidida de los enfoques ontológicos y epistemológicos de la complejidad, en poblaciones pequeñas, son, en nuestro medio, muy escasos cuando no inexistentes. Por lo tanto, los problemas del desarrollo y la participación de las familias y entornos comunales en el sostenimiento de los mismos continúan siendo motivo de investigaciones en el campo.

A medida que los niños crecen, aumenta la influencia del medio que los rodea, y las diferencias en el desarrollo psicomotor entre los niños que reciben distintos niveles de estimulación se profundizan. Para llevar a cabo la detección oportuna de los problemas de desarrollo (“denominados nuevas morbilidades”) fueron dise-

ñadas pruebas objetivas especialmente para su detección llamadas de pesquisas destinadas a ser aplicadas en consultorio de pediatría general, escuelas, etc. Pruebas sencillas destinadas a detectar individuos probablemente enfermos en una población presuntamente sana, se han confeccionado en muchos países, pero estos instrumentos requieren siempre ser sometidos a pruebas de validación antes de ser implementados (Pascucci M y col 2002).

Entre 1988 y 1994, el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", convocó a más de 200 pediatras que llevaron a cabo la evaluación del desarrollo psicomotor de 3.573 niños sanos de todo el país (Lejarraja y col 1997).

Como resultado de este trabajo, se logró la construcción de un verdadero instrumento que tomó el nombre de Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE). Esta prueba ya ha comenzado a aplicarse en muchos ámbitos del país.

Sesa y col (2001) analizaron el desempeño en pruebas de desarrollo en una cohorte de niños nacidos en la ciudad de Córdoba en mayo de 1993 y compararon los resultados con los obtenidos por el Programa Nacional Colaborativo de Evaluación del Desarrollo en niños menores de seis años (PRUNAPE). El bajo rendimiento encontrado en conductas que dependen de actitudes cognitivas o de procesos de simbolización y socialización, alertaron sobre el riesgo de desatención de este aspecto de la salud integral infantil que, sin dudas, repercutirá posteriormente en las posibilidades de aprendizaje sistemático y rendimiento escolar.

En la ciudad de Bariloche, (2010 - 2012), se realizó estudio de desarrollo psicomotor infantil empleando la PRUNAPE. Sobre un total de 152 niños asistían a jardines privados y municipales, El porcentaje de niños que fracasaron en la PRUNAPE fue del 27%. En seis de ocho pautas de lenguaje, el porcentaje de niños de jardines inicial municipal que pasaron la pauta fue significativamente inferior al de jardines privados, y en tres pautas estuvo por debajo del nivel nacional. Las variables asociadas con mayor frecuencia a pautas de desarrollo alteradas fueron la falta de lectura, el bajo peso al nacer y el menor nivel de educación parental (Vasconib T y col 2013).

Respecto a evaluación de la estimulación en el hogar, diversos estudios han utilizado el in-

ventario HOME (Calidad del ambiente del hogar) para evaluar calidad del ambiente del hogar concluyendo que el inventario HOME logra captar mucho de la estructura ambiental del hogar de los distintos grupos estudiados, resultando ser una herramienta útil para medir la calidad del ambiente (Bradley, Mundfrom, Whiteside 1994), (Bustos Correa y col 2001).

En Chile y Argentina se han realizado algunas aplicaciones de este instrumento con niños menores de tres años de realidades socioeconómicas pobres y medio alto, demostrando que los datos otorgados por el inventario HOME se relacionan estrechamente al desarrollo cognitivo del niño, y que su utilización como indicador de calidad ha sido positiva (Vasconib, T y col 2013) (Mathiesen M y col 2001).

En el campo de la salud, las redes sociales han sido utilizadas con perspectivas heterogéneas y desde diferentes disciplinas; mostrando la incidencia directa de las redes sobre el nivel de bienestar durante el padecimiento de una enfermedad o en la resistencia a ciertas enfermedades y/o en las probabilidades de contagio. También, se presentan trabajos que dan cuenta de los beneficios que proporcionan las redes sociales en la aceleración de los procesos de curación, en la búsqueda del tratamiento, en el cumplimiento de actividades y/o en la obtención de recursos, entre otros aspectos (Enríquez Rosa, 2000), (Bronfman 2001), (Sluski 2002), (Dabas E y Perrone N 2006), (Pasarín L 2009).

Respecto a las redes sociales, apoyo social y desarrollo de los niños, contribuciones al tema se han desarrollado a través de diversas investigaciones con distintos enfoques. (Roldán L 2016) (Moreno- Zavaleta M 2016) (Delgado J 2007).

Si bien el grupo de investigación de ambiente y salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER viene investigando las patologías neonatales en los últimos años y si bien, se podría seguir enumerando largamente los aportes a las dimensiones de este estudio, lo cierto es que, en cuanto al cariz particular que el reviste, el panorama en nuestra región es mucho más raleado y la poca producción existente es de muy escasa circulación (Pepe J y col 2005), (Pepe J y col 2007), (Pepe J y col 2015).

En particular, en el área en la que se llevará a cabo el estudio, es inédita en la región y creemos que ella puede abrir las puertas a una serie

de estudios futuros que permitan disponer de un muestrario suficientemente rico que permita a la Facultad de Ciencias de la Salud continuar en el coro de las instituciones preocupadas por la Epidemiología Ambiental de la Familia y la Comunidad. Dan cuenta de esto el compromiso que se asume con la Secretaría de Salud del Municipio de Concepción del Uruguay y la Filiar Río Uruguay de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Justificación de la investigación

La hipótesis sustantiva que orienta la investigación consiste en sostener que la resolución de las morbilidades de la infancia se encuentra condicionada y determinada por el comportamiento de los distintos niveles en que se organiza el medio ambiente humano (familia, comunidad, estado, sociedad civil), pero conforme a una dialéctica compleja en la que lo que es medio externo en cierto nivel de integración, se transforma en medio interno, en otro nivel.

La justificación de esta investigación se fundamenta en la penosa constatación de un sostenido aumento del valor de los indicadores de patología alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil en nuestro medio.

Estas aseveraciones son expresiones de problemáticas mucho más amplias y profundas, y que no sólo la hacen comprensible, sino que contienen las claves para orientar cualquier acción que intente resolverla. Las investigaciones científicas más recientes coinciden en señalar que los problemas de la infancia se deben en una importante medida a una trama de causas, la mayoría de las cuales son evitables.

Según datos de investigaciones anteriores realizadas por el equipo, en los territorios y espacios estudiados en la ciudad de Concepción del Uruguay, el bajo peso al nacer se asoció con desigualdades intra espaciales barriales. La casi homogeneidad que se encontró en 3 zonas de la ciudad, en cuanto a la relación del mismo con el mal control del embarazo, permitió inferir que las políticas o el sistema de salud, a través de programas con una visión simplificada, debería correrse a una visión compleja basada en una epidemiología ambiental espació-territorial para poder mejorar o revertir esta problemática (Pepe J y col 2015).

La evaluación del ambiente que rodea a los niños de 5 años escolarizados de la ciudad y su

influencia en el desarrollo, tema del último trabajo de investigación que terminó, al comienzo del año, arrojó datos del desarrollo y creciente de estos niños. Un dato importante es el 24,5 % de los niños evaluados, según muestreo estadístico ($n = 219$), presento sospecha de padecer problemas de desarrollo según la PRUNAPE. De estos el 42 % ($n=22$) provienen de hogares con pobre estimulación para el desarrollo y en uno de cada dos las madres no habían completado un nivel de educación secundario y 23% son hogares son de nivel socioeconómicos bajos. Cabe destacar que en este grupo también se han encontrado niños que provienen de hogares estimulantes ($n=31$), con madres, en su mayoría, con más de 12 años de educación formal

En forma similar, en el grupo de niños que se desarrollan típicamente se encontró que el 34% provienen de hogares no estimulantes ($n=56$), mientras que el 66% son de hogares estimulantes. Según los aspectos educativos de las madres, se encontró que 1 de cada 4 niños del primer grupo son hijos de madres que no finalizaron el secundario. Estos niños, que en las condiciones socioambientales adversas estudiadas se desarrollan típicamente, son los llamados niños resilientes (26%).

En síntesis, se encontró que el 6% del total los niños evaluados, presentó sospecha de padecer retraso global del desarrollo, en ambientes de privación de estímulos y calidad educativa materna. Por otro lado, el 20% ($n=43$), se desarrolló típicamente, aun en las mismas condiciones de privación de estímulos y de calidad educativa. El desarrollo en estos niños aparece asociado a las subescalas del Home “diversidad de experiencias” y “estimulación al comportamiento académico”.

A la luz de lo expuesto, una parte de los niños con desarrollo típico (34,4%) están más expuestos a ambientes poco propicios, siendo más evidente la importancia del “microsistema hogar” como agente mediador que cumple la función de suplir esas necesidades o la existencia y naturaleza de las interconexiones con otros ambientes complementarios –talleres barriales, comedores escolares- permitiendo contextualizar los fenómenos del desarrollo en los varios niveles del mundo social.

Frente a esta realidad, abordar el estudio de estos niños es una tarea que se justifica por sí misma. Se conocen algunos elementos que co-

adyuvan a establecer como imperativa la ampliación de los estudios existentes y profundizar en aquellos aspectos que puedan propiciar la recuperación e inserción de los niños con alteraciones del crecimiento y desarrollo psicomotor con su entorno social más inmediato.

Desde una dimensión social y económica, se trata de una problemática de relevante. La relevancia social es un hecho incuestionable dado que este grupo de niños ingresa al mundo con marcas biológicas, psicológicas y culturales que sin duda condicionarán y/o determinarán su vida futura, afectando las probabilidades de que estas alteraciones se asocien con episodios de fracasos escolares, laborales e incluso, de violencia en sus distintas modalidades. En cuanto a la relevancia económica, cabe recordar que las patologías de las infancias consumen una importantísima cuota de los recursos y esfuerzos familiares, profesionales y materiales.

Pero también se trata de una problemática de relevancia teórica, puesto que, si bien hay numerosas experiencias que muestran prácticamente que la mayor eficacia en la resolución de estos problemas no pasa por agregar nuevas tecnologías medicalizantes, sino por desarrollar programas preventivos orientados hacia los llamados “factores de riesgos ambientales”. Sin embargo, es cierto que estos enfoques ambientalistas todavía no han conseguido un estatuto científico suficientemente sólido y consagrado (ni en lo teórico ni en lo experimental) como para ser universalmente reconocidos por todos los actores con capacidad de decisión política en la problemática.

La alternativa de promover la formación de redes inteligentes integradas por centros de salud infantil y de rehabilitación, etc., para proteger áreas definidas, sin superposiciones ni omisiones, etc., implican esfuerzos de programación que necesitan insumos cognoscitivos importantes, no sólo datos, sino, sobre todo, categorías de análisis suficientemente ricas y operantes como para producir diagnósticos de situación válidos y confiables.

Se sabe que la programación científica de la acción humana consiste en encadenar las acciones de manera eficaz para realizar ciertos productos, pero, no por ellos mismos, sino con vista a producir ciertos impactos muy determinados en las situaciones dadas a fin de que ellas evolucionen en la dirección fijada por los fines. La compren-

sión de la relación entre los productos que se quieren producir, y los propósitos que se quieren lograr con esos productos ponen en juego (implícita o explícitamente) un conjunto crucial de hipótesis acerca de las cadenas, redes o ciclos causales que vinculan unos y otros.

Escoger entre producir nuevos centros de atención infantil para actuar sobre los sujetos mismos, o en su defecto, redes de servicios para actuar sobre los factores ambientales, es una decisión que debe ir mucho más allá de una mera cuestión de “escuelas”, modas o corrientes sanitaristas. Exige, por el contrario, un debate reflexivo y científico circunstanciado que provea de respuestas teóricas suficientemente válidas para aumentar las probabilidades de éxitos.

Es cierto que hay un repertorio nutrido de presuntos “factores de riesgos ambientales” a los que se le puede imputar carácter causal en la determinación de las alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil, pero también es cierto, que hay una enorme cantidad de evidencias de que los “factores ambientales” no actúan como meras causas externas, que sujetos sometidos a los mismos factores ambientales no reaccionan de la misma forma, y que no es posible desconocer la importancia de los “factores internos”. Estos hechos como lo sostenía Juan Samaja, tornan necesario reexaminar los marcos conceptuales mediante los cuales se determina lo que es externo y lo que es interno, y, en consecuencia, las fronteras (fijas o móviles; estáticas o dialécticas) entre ellos.

¿En qué medida la familia constituye un factor externo (ambiental), o interno (organísmico) en las alteraciones del crecimiento y desarrollo infantil? ¿Cuáles son las influencias del ambiente en el crecimiento y desarrollo de los niños de 3 años?

¿Qué relaciones se establecen entre el desarrollo psicomotor de los niños y la conformación de las familias? ¿Cuál es la influencia de los hogares de distintos contextos sociales en la estimulación de desarrollo psicomotor de los niños de 3 años? ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre la calidad del ambiente familiar y el desarrollo psicomotor de los niños? ¿En qué medida las redes sociales de las familias actúan de apoyo para el desarrollo de los niños “resilientes”? ¿Qué papeles cumplen dichas redes?

Queda a la vista, entonces, que la relevancia teórica de esta problemática neonatal es inse-

parable y acompaña de manera solidaria a su relevancia social y su relevancia económica.

Priorizando los interrogantes anteriores y teniendo en cuenta que en Concepción del Uruguay no existe lo que podríamos llamar un mapeo de las infancias de 3 años en cuanto al crecimiento y desarrollo psicomotor, para prevenir los problemas del fracaso escolar se considera prioritario investigar esta problemática.

Estas cuestiones deben ser resueltas tanto para examinar el potencial de eficacia de los centros de atención infantil y escolares, como los de las posibles redes de apoyo o servicios entre todos estos eslabones posibles: sujetos, familias, redes familiares y vecinales, centros de salud, escuelas, etc.

Los Objetivos

Describir el crecimiento y desarrollo psicomotor en relación a un grupo de variables relevantes vinculadas a la intervención temprana de niños, sus familias y sus entornos en el lapso que va del 2019 al 2021(inclusive).

Comparar las características de un grupo de familias de distintos entornos comunales y medioambientales a fin de elaborar hipótesis sobre las redes sociales que de alguna manera influyen en el crecimiento y desarrollo psicomotor de las infancias.

Revisar, a la luz de los hallazgos empíricos en el estudio comparativo, los marcos conceptuales con que se analizan los factores ambientales y someter a prueba el valor teórico y operante del tratamiento dialéctico de las categorías dicotómicas: i) medio interno / medio externo, y ii) medio condicionante / medio determinante.

Propuesta metodológica

Las metodologías generales que serán empleadas en esta investigación son:

-Registros de datos. Se tomarán los años 2018 al 2020 capturando los niños de 3 años que concurran a los centros de salud por control pediátrico (según muestreo) que se incluirán en un protocolo de crecimiento y desarrollo psicomotor. Se utilizará un muestreo probabilístico estratificado, consistiendo los estratos en cada uno de los centros de salud mencionados anteriormente. El tamaño de la muestra se seleccionará a partir de la población concurrente

a cada centro de aplicando el criterio de afijación proporcional. Al trabajar con una encuesta de objetivos múltiples, la determinación del tamaño muestral se centrará en las características que sean de interés fundamental para la investigación. Dado que la expresión que relaciona la precisión con el tamaño muestral depende de valores poblacionales que generalmente se desconocen, se tomará información procedente de investigaciones anteriores. Se trabajará con un nivel de confianza del 95%. Se incluirán variables socioambientales familiar y comunitario, y se geo referenciarán barrio al que pertenecen, realizar un estudio ambiental (saneamiento básico y de servicios, accesibilidad al servicio de salud, etc.), a fin de encontrar homogeneidades.

-A cada niño se lo evaluará clínicamente aplicando los test seleccionados para crecimiento y desarrollo mediante las técnicas específicas previo consentimiento de los padres. Para el desarrollo se aplicará las pautas de motricidad fina y gruesa, personal social y de lenguaje correspondientes a la edad de 3 años de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico de la escala propuesta para el Programa Nacional Colaborativo (PRUNAPE) elaborada por el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Nacional de Pediatría “Prof. Dr. J. P. Garrahan”. Según los autores, es un “conjunto de pruebas y preguntas compuesta por 229 pautas de desarrollo, seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: fácilmente realizables por pediatras, presentes en algunas de las pruebas de evaluación del desarrollo más comúnmente utilizadas como la de Bayley (1997), Gessell (1952), Griffiths (1954) con cobertura de las cuatro principales áreas de desarrollo: personal-social-cognitiva, lenguaje, motriz fina-adaptativa y motriz gruesa. Coincidiendo con Sesa y col. las razones a elegir este instrumento son varias: 1º) fue elaborado en nuestro medio, lo que permitiría comparar los resultados de nuestros niños con los del resto del país; 2º) las técnicas de evaluación creadas en el extranjero no cuentan con una adaptación estadística local y 3º) incluye las relaciones vinculadas que no son consideradas por otras escalas, pero que son ingredientes fundamentales para lograr un buen desarrollo y una mejor salud mental.

Para el estudio antropométrico se medirá peso y longitud/estatura utilizando balanza digital portátil Tanita UM-061 (de 100 g precisión) y

pediómetro con escala milimétrica según técnicas estandarizadas. (Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo, 2001).

-Entrevistas a informantes familiares claves, en muestras de familias obtenidas con propósito comparativo. En particular, se realizarán entrevistas para la aplicación de una encuesta elaborada utilizando como modelo el inventario HOME, la evaluación de la estimulación del ambiente familiar. Como así también una valoración de variables relevantes para la condición de vida de dichas familias (estratos socioeconómicos, contacto social, división de trabajo doméstico) y características de la red social de apoyo percibida como importante para el crecimiento y desarrollo de los niños. A medida que avance la entrevista la información será ingresada al software EgoNet¹ en un cuestionario diseñado previamente con ciertas características de la red (tamaño o extensión de las redes, intensidad de la relación, sexo y edad de las personas nominadas, frecuencia de la relación, tipo de ayuda recibida, porcentaje de familiares en la red, etc.) y de la estructura (densidad de las redes, clústeres o grupos) de las redes personales. Asimismo, se visualizarán cada una de las redes obtenidas, permitiendo el análisis de las mismas

-Entrevistas a informantes de las instituciones barriales, centros de salud comunitarios, etc., como medios para producir un diagnóstico del potencial para la promoción y organización de redes sociales de sostén.

-Entrevistas a informantes calificados para explorar y describir la situación nutricional, la densidad vincular de las redes vecinales, las historias escolares, las historiales laboral, etc., en tanto representaciones del medio ambiente social.

1 1 EGONET: un programa diseñado por C. McCarty para la recolección y el análisis de datos egocéntricos. Su diseño permite que el investigador incorpore las preguntas que desea hacer y produce, entre otras cosas, un conjunto de datos donde la unidad del análisis es la persona que responde. Disponible en <http://sourceforge.net/projects/egonet>

Bibliografía

- Bayley N. (1969). *Manual for the Bayley scales of infant development*. California, EE.UU.: The Psychological Corporation.
- Bradley R, Caldwell B. (1984) The HOME inventory and family demographics. *Dev Psychol*; 20(2):315-20. DOI: 10.1037/0012-1649.20.2.315
- Bradley H; Mundfrom and L. Whiteside. (1994). A Factor Analytic Study of the Infant-Toddler and Early Childhood Versions of the HOME Inventory Administred to White, Black, and Hispanic American Parents of Children Born Preterm. *Child Development* 65:880-888. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1994.tb00790.x>
- Bronfenbrenner U. (1979). *The ecology of human development*. Cambridge: Harvard University Press (existe edición en castellano en *La ecología del desarrollo humano*, Barcelona: Paidós, 1987.ISBN 9788475094441.
- Bronfman M. (2001). *Como se vive se muere. Familia, redes sociales y muerte infantil*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Bustos C, Herrera M, Mathiesen M. (2001) Calidad del ambiente del hogar: inventario HOME como un instrumento de medición. *Estud Pedagog (Valdivia)*; 27:7-22. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052001000100001>
- Cohen S, Syme L. *Apoyo social*. Madrid (ES): Ed. Elsevier; 1986.
- Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo. (2001) *Guías para la evaluación del crecimiento*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Pediatría
- Dabas E. (2001) *Red de redes: las prácticas de la intervención en redes sociales*. Buenos Aires (AR): Ed. Paidós; 2001.
- Dabas E. (2005) *Redes sociales, familias y escuela*. Buenos Aires (AR): Ed. Paidós.
- Dabas E y Perrone N (2006). "Redes en salud". En: Dabas E. (comp.) *Viviendo Redes: experiencias y estrategias para fortalecer la trama social*. Buenos Aires: Ed. Ciccus.
- Delgado J, Domínguez AM, Lobo MA. Red de apoyo a las familias con niños que asisten a los comedores comunitarios en 127 un barrio capitalino, Santiago de Estero, Argentina. *Texto contexto enfermagem*, 2007; 16(4): p.636-44. 636-644. <https://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072007000400007>
- Enríquez Rosas R (2000) *Redes sociales y pobreza: mitos y realidades*. Revista de estudios de género. La ventana. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88412392004>
- Gessell A. (1952) *Diagnóstico del desarrollo*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1952:29-46.
- Grantham Mc G, Cheing YB, Cueto S, Glewwe P, Richter L, Strupp B and the International Child Development Steering Group. (2007) Child development in developing countries. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *Lancet*. Jan 6; 369(9555): 60-70. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60032-4
- Griffits R. (1954) *The hability of babies: A study on mental measurements*. New York: Mc Graw Hill.
- Hatt LE, Waters HR. (2006) Determinants of child morbidity in Latin America: a pooled analysis of interactions between parental education and economic status. *SocSciMed* 62: 375-86. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.007>
- Lejarraga, H, Kelmansky, D M, Passucci, M C, Masautis, A, Insua, I, Lejarraga, C, & Nunes, F. (2016). Evaluación del desarrollo psicomotor del niño en grupos de población como indicador positivo de salud. *Archivos argentinos de pediatría*, 114(1), 23-29.
- Lejarraga H (2008) La interacción entre genética y medio ambiente. En: Lejarraga H. *Desarrollo del niño en contexto*. Buenos Aires: Paidós. Págs.99-140.
- Lejarraga H, Kupritzky (1988) S. Evaluación del desarrollo del niño de 0 a 5 años. Programa Nacional Colaborativo. Coordinación Crecimiento y Desarrollo. Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. J.Garrahan. 1988
- Mathiesen M, Herrera M, Merino J, Villalón M, et al. (2001) Calidad educativa familiar y desarrollo infantil del párvulo. *Paideia. Rev Educ* 30-31:61-79.
- Ministerio de Salud. Dirección de estadística e información de Salud. <http://www.deis.msal.gov.ar/wpcontent/uploads/2018/04/IndicadoresBasicos2017.pdf>
- Myers R. (1993) *Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera infancia en el tercer mundo*.

Washington, D.C. OPS. Publicación científica 545.

Moreno- Zavaleta M T, Granada- Echeverri, P. (2014). Interacciones vinculares en el sistema de cuidado infantil. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 12(1), 121-139. <https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1216052513>

Pasarin L (2009) Estudio antropológico de redes sociales de madres adolescentes durante el embarazo. Avá. *Revista de Antropología [en línea]* Disponible en: <http://www.autores.redalyc.org/articulo.oa?id=169013838011> ISSN 1515-2413

Pepe J, Mingillo L. et al (2005) *Sobreviven, ¿Cómo y dónde?. Seguimiento de los Recién Nacidos con Bajo Peso al Nacer*. Universidad Nacional de Entre Ríos – Fac. de Ciencias de la Salud. INEX, Concordia, E.R.

Pepe J, Mingillo L. (2007) “Reconstrucción de los escenarios que dificultaron la visita prenatal de las madres que dieron a luz bebés de bajo peso al nacer” presentado en IV Congresso Brasileiro Ciências Sociais e Humanas em Saúde, X Congressoda Associação Internacional de Política de Saúde – Equidade, tal Ética e Direito à Saúde: desafios à Saúde Coletiva namundialização – realizados entre el (2007). Salvador, Bahía, Brasil.

Pepe J L et al (2015) Capacidades socioambientes para el crecimiento y desarrollo de niños con bajo peso al nacer-pretérmino. *Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento- Vol 5, No 5 (2015) pág187-198. EDUNER. ISSN 2250-4559*

Pepe J y Mingillo L. (2015): *Epidemiología ambiental de los problemas ambientales* En: JA Reichenbach; SM Fontana y W Gómez (Eds), *Pediatría en Red*, (1ªEd, pp.60-66). La Plata, Argentina: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Pascucci M, Lejarraga H, Kelmansky D, Álvarez M, et al. (2002) Validación de la prueba nacional de pesquisa de trastornos de desarrollo psicomotor en niños menores de 6 años. *Arch Argent Pediatr*;100(5):374-84

Roldán L, Ayala M., Pérez D. & Romero, N. (2016). Redes sociales de apoyo a la crianza de los menores en etapa escolar primaria. *Rev. Cient. Gen. José María Córdova* 14(18), 73-95

Santillán, L. (2010). Las configuraciones sociales de la crianza en barrios populares del Gran Buenos Aires. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8 (2), 921-932.<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77315155011>

Sesa S.; Frasson A. M.; Sabulsky J. & Agrelo F. (2001). Análisis Longitudinal y Comparativo del desarrollo infantil en la ciudad de Córdoba. *Arch.argent.pediatr*; 99(2).

Sluski, Carlos. 2002. “De como la red social afecta a la salud del individuo y la salud del individuo afecta la red social”. En: Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.). *Redes. El lenguaje de los vínculos. Hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil*. Argentina: Ed. Paidós.

Stolkiner A. (2004) *Las familias y la crisis. Cuestiones de infancias: Revista de Psicoanálisis con niños*.04. vol 8. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 137-151.) <http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/225>

Torralva T, Cugnasco I, Manso M, Sauton F, et al. (1999) Desarrollo mental y motor en los primeros años de vida: su relación con la estimulación ambiental y el nivel socio-económico. *Arch Argent Pediatr* 97(5):306-16.

Vasconib TS, Gianninic G, Pittauc C. (2013). Desarrollo psicomotor infantil y su relación con las características sociodemográficas y de estimulación familiar en niños de la ciudad de Bariloche, Argentina. *Arch Argent Pediatr*, 111(5), 384-390.

***Dr. Jorge Luis Pepe**

Decano. Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Entre Ríos.

****Mg. Bioq. Liliana Mingillo**

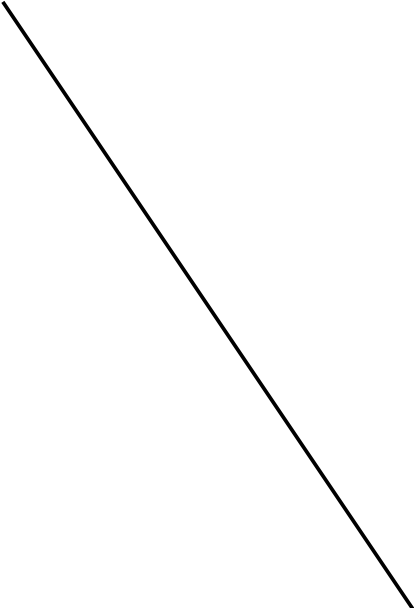
Docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Entre Ríos.

*****Lic. en salud ambiental Claudia Rocca**

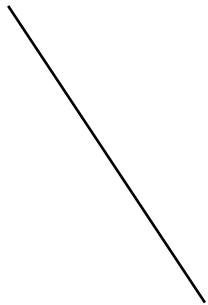
Docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Entre Ríos.

******Dra. Silvia Masini**

Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Entre Ríos.



NÚCLEO **ESPECIALISTAS**



LLANTO EN EL NIÑO



DRA. EVA JOSEFINA QUINTEROS FLEITES*

Cuando los pediatras y/o neonatólogos realizan sus evoluciones clínicas en las salas hospitalarias, pueden utilizar algunas frases en su valoración de los pacientes atendidos. Hace años solía escribirse “niño con buena vitalidad, llanto fuerte, buena succión y quizás piel y mucosas bien coloreadas y los reflejos presentes (Acorde a la edad y enfermedad).

El llanto fuerte es considerado en ocasiones como un signo de que el bebé está bien. Con frecuencia el pediatra se encuentra en su desempeño profesional con niños que entre el nacimiento y hasta los tres meses lloran, y ello preocupa a la madre, al esposo, a las abuelas y hasta los vecinos. Claro que a los pediatras les preocupa, pues en ocasiones puede ser manifestación de enfermedades; en este período puede que solo lloren por las temperaturas elevadas o sea por el calor o por el frío, por tener sed en climas muy calurosos, por estar mojados o por estar con rozaduras o lesiones en la zona perianal, más frecuentes en el siglo de los pañales desechables y donde mamás que no tienen posibilidades económicas y o sociales, no cambian con la frecuencia requerida a los bebés y al examinarlos pueden tener amplias zonas de dermatitis del pañal y otras afecciones dermatológicas. También la picadura de un insecto y un hilo enredado en un dedo, refieren muchos textos. En los primeros días puede que no se haya diagnosticado una fractura de clavícula y llore sin cesar al colocarlo a mamar. Muchas son las afecciones que hay que descartar ante un niño que llora, casi todos invocan a una otitis y muchos ni piensan que quizás quiere que lo arrullen o lo mimen o lo levanten, y con solo hacerlo, desaparecen los gritos. Hay que cuidar en tiempos

de circulación de virus, pues las miocarditis del lactante pueden dar como manifestación clínica un llanto que no se calma y se trata de una Miocarditis. También las Meningoencefalitis pueden provocar llanto; otras muchas afecciones como invaginación intestinal y torsión de un testículo que conllevan una intervención de un cirujano.

No se pretende publicar cifras o citar causas del llanto, un fenómeno bastante complejo y difícil de abordar, también con diferentes formas de darle respuesta a diferentes edades y bajo circunstancias variadas; lo que se desea es alertar a los que empiezan a transitar por el campo de la pediatría en la diversidad de diagnósticos y cómo acorde a las edades y otros síntomas se puede proceder de diferente forma. Por todo ello, no se pretende dar recetas, pero si en los primeros meses de vida, a ese llanto que si bien es cierto que puede ser la manifestación de una enfermedad, y que puede o no ser grave, pero en la pediatría ambulatoria puede ser atribuido por madres, abuelas y vecinas, al proceso de alimentación y específicamente suele ser interpretado como hambre o niño no satisfecho; en muchas oportunidades lleva a la introducción de otras leches artificiales, y de otros alimentos diferentes a la leche materna, alimento que debe ser ofrecido de forma exclusiva hasta los seis meses de vida.

Si se trata de un llanto que se caracteriza por presentarse a determinadas horas y cuando además se encuentra que los niños y las niñas gozan de salud y se les considera sanos, entre los períodos de llanto, se trata del denominado Cólico infantil o llanto excesivo del lactante, que suele presentarse en el primer trimestre de la vida y que desaparece a los tres meses, sin

tratamiento medicamentoso. Se busca aliviar a las madres y familias muy angustiadas y por ello se les debe ofrecer orientaciones a los padres y abuelos o familia y vecinos del bebé en cuestión.

Durante muchos años se observó que a la misma hora todos los días acudían en busca de ayuda madres y en ocasiones las familias, por las crisis de llanto en los niños. Muchas decían llorando: No se llena, llora sin cesar todos los días a esta hora (6pm a 1am). Claro que no sabía aún que ello estaba descrito, pero siempre les animaba a tranquilizarse y a ofrecer el pecho a libre demanda y tener paciencia. Años más tarde, tras una extensa búsqueda bibliográfica, se pudieron encontrar varios trabajos que se referían a esos episodios de llanto que hasta ese momento había interpretado como gases intestinales. Un trabajo de los revisados hablaba de un autor que había estudiado 100 niños y que después que se quedaban dormidos les tomó un Rx Abdomen y se evidenciaban abundantes gases en todo el tubo digestivo pero los niños estaban profundamente dormidos. El autor aseveraba que el cólico infantil no tenía ninguna relación con la presencia de gases intestinales. No realicé ninguna investigación en lo personal, pero si por más de 30 años me dediqué a enseñarles a las mamás y a las enfermeras y a las familias, de acuerdo a las acciones y recomendación de los autores:

- ✓ Lo primero que se debe hacer cuando un niño llora es levantarlo antes de los 90 segundos. Eso fue muy importante y aún lo sigo repitiendo.
- ✓ No realizar movimientos vigorosos (le denominé la abuela batidora) por el movimiento de arriba hacia abajo enérgico pues ello hace que lllore más.
- ✓ Ponga su cara y la cara del bebé bien pegados, contacto piel a piel y su olor es especial.
- ✓ Hablarle y susurrarle al oído canciones de cuna o simplemente un susurro imperceptible.
- ✓ Recomendar a la mamá acerca de buscar apoyo en amigas y otros familiares para en esa “hora pico” usted pueda estar tranquila y dedicarse a pasearlo despacito, hablarle y susurrarle.
- ✓ Hacer que el papá del bebé también participe en estos momentos.
- ✓ Explicar que eso es transitorio y al pasar

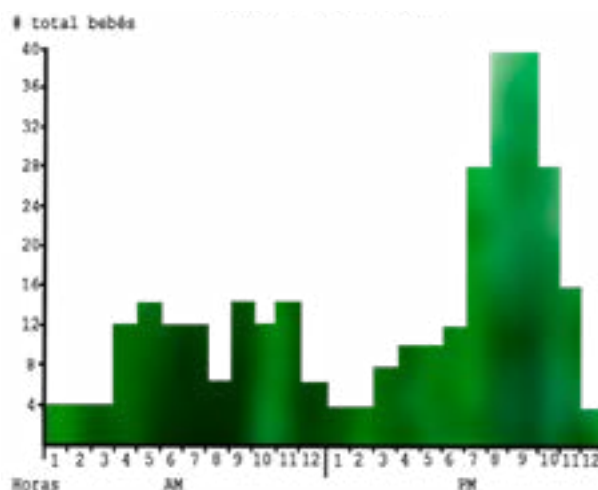
los meses no le ocurrirá más.

- ✓ Alimentar solo a pecho materno y hacerlo a libre demanda o sea cada vez que demande.

Años más tarde, un nuevo reporte me hizo sentir aún más tranquila. Los niños lloraban pues estaban atravesando por un período de crecimiento rápido y ello pudiera vincularse a la denominada “*crisis de la lactancia*”.(ver OPS)

Alerta con los denominados períodos de crecimiento rápidos, ellos llevan a las denominadas crisis de lactancia y de forma interesante se corresponden con los períodos de llanto excesivo descritos desde años por Brazelton. Resulta muy interesante que efectivamente una de las causas más frecuentes de lactancia artificial referidas por las madres en estudios realizados desde hace años, es el llanto del niño. Ello deben conocerlo los profesionales y las madres. Estas últimas podrán tener todo listo para atenderles, levantarlo en sus brazos y ofrecerle todo su tiempo. Además de explicarles los horarios de llanto de los lactantes, en especial el de mayor porcentaje de llanto, ese llamado “horario pico”; entre las seis de la tarde y la una de la madrugada. Si la familia y los padres conocen de estos horarios en que normalmente los niños lloran más, serán más receptivos a las orientaciones sobre el ofrecer pecho a libre demanda, sin considerar la posibilidad de que el niño llora por hambre; a los tres meses suelen desaparecer las crisis de llanto en este horario, lo cual a veces es mejor no decirlo a los padres, pues podrían

Tiempo que aparecen agitados los lactantes de 3 meses de nacido



Tomado de artículo de Brazelton.

afanarse, por tener que esperar hasta esa fecha, para que desaparezca el llanto excesivo; otras veces no se dice y van pasando los días y las crisis se toleran con más paciencia.

El llanto y los períodos de crecimiento rápido

Fragmentos de Brazelton del libro Lactancia materna. Regalo de vida.

Este apartado se dedica al llanto, por ser una de las causas más frecuentes de interconsulta y en ocasiones de incorporación de otra leche sin la prescripción médica. El llanto “enloquece”, o mejor dicho desordena y pone ansiosos a todos los miembros de la familia. Es por ello que se decide incorporar su análisis y posibles soluciones; las familias deben conocer todo lo que a continuación se explicará. Usted, como profesional debe hacer que esta información llegue a todo el entorno en que vive el bebé oportunamente, antes que sea demasiado tarde.

Hay que estar alerta con los denominados períodos de crecimiento rápidos, ellos llevan a las denominadas crisis de lactancia (UNICEF-OMS, 1993) y, de forma interesante, se corresponden con los periodos de llanto excesivo descritos desde hace años por Brazelton.

Resulta muy interesante que, efectivamente, una de las causas más frecuentes de lactancia artificial referidas por las madres en estudios realizados desde hace años, es el llanto del niño. Desde algún tiempo atrás se describen los períodos de crecimiento rápido; si se analiza la asociación entre la mayor demanda del niño por estar transitando esos períodos y sus crisis de llanto, se esclarecerá este tema. Este aspecto debe ser conocido por los profesionales y las madres.

Hay determinados horarios en que el niño suele llorar más. Brazelton destaca el horario pico -ese que suele sacar a las familias de su estabilidad emocional- que algunos denominan de llanto excesivo o cólico infantil, entre las seis de la tarde y la una de la madrugada. Muchos padres con sus niños acuden a las casas de sus amigos pediatras por este tema, lo cual motivó a la autora a revisar esa vinculación con la lactancia materna, tan interesante y poco estudiada en las carreras universitarias.

Si la familia y los padres conocen de estos horarios, serán más receptivos a las orientaciones sobre el ofrecer pecho a libre demanda, sin ofre-

cer otro tipo de alimentación. A los tres meses suelen desaparecer las crisis de llanto en este horario, pero esto es mejor no decirlo a los padres, pues podrían afanarse por tener que esperar hasta esa fecha para que desaparezca el llanto excesivo. Cuando no se les informa esto, pasan los días y las crisis se toleran con más paciencia.

Hay autores que recomiendan que la madre descanse, tome siestas y busque la ayuda de amigos y parientes, lo cual es muy importante. El contacto piel con piel entre la madre y el bebé puede calmarle; también el hablarle en voz baja y suave o susurrarle al oído. Hay países en que las madres mantienen a los bebés cargados, aún en sus sesiones de trabajo, y nunca se les escucha llorar, por ello se recomienda que carguen los niños, aunque no estén llorando, pues ello disminuye las crisis de llanto.

Se considera que toda persona que va ayudar a una madre que amamanta a su hijo debe conocer del llanto de los niños y las niñas y sus posibles causas, los diferentes horarios, su frecuencia y la intensidad del llanto. Se debe explicar a las madres -aún antes del nacimiento del bebé- que este llorará por múltiples causas, entre las que se destacan: por estar orinado o mojado (como dicen algunos autores), por tener sed, calor, sueño y también por deseos de que los arrullen, los mimen y los acaricien.

Al analizar las causas del llanto no deben olvidarse algunos alimentos que las madres ingieren, en especial si lo hacen en exceso, entre ellos están el café, el chocolate, el té negro, los líquidos con Cola y el hábito de fumar en la madre. No olvidar que, en ocasiones, las mamás que ingieren leche de vaca en cantidades excesivas en su dieta pueden sensibilizar a los niños con antecedentes de atopía, pudiéndose producir episodios de llanto excesivo como manifestación de alergia a la proteína de la leche de vaca. En estos casos la madre debe reducir su ingesta de leche de vaca, al menos, a la mitad de un litro en el día y esperar la respuesta del niño. En ocasiones la madre debe abandonar por un tiempo la ingestión de leche de vaca.

Casi todas las madres y familiares con niños pequeños suelen relacionar el llanto en primer lugar con la necesidad de alimento, por ello por años se ha tratado de explicar que el llanto no siempre es señal de hambre y que al niño que llora, no siempre hay que alimentarlo; algunos

autores resaltan la necesidad de “levantarlo” y hacerlo de inmediato, antes de los 90 segundos... *El padre levanta a su bebé y lo coloca en el hombro... La mamá coloca a su bebé piel a piel, en su regazo, Niño en contacto piel a piel con su mamá.*

Por ello se debe aconsejar a la familia “...si el niño comienza a llorar, deje lo que esté realizando y levántelo, si está acomodándole el pañal, déjelo así y levántelo y arrúllelo, seguro que se calmará más rápido”.

El contacto piel a piel calma al bebé, así que colóquelo de forma que sea positivo este efecto combinado de alzarlo o levantarlo y colocarlo piel a piel.

A estas crisis –que desaparecen a los tres meses– se les suele denominar cólico infantil. En realidad, se le denomina cólico infantil; se trata de niños sanos que entre los episodios de llanto están bien, aumentan de peso y están contentos.

Importante resulta la aclaración de que los niños pueden llorar, además, a causa de estar enfermos por variadas causas: la fractura de clavícula en los recién nacidos, la otitis, la insuficiencia cardíaca, la torsión de un testículo, la invaginación intestinal, las meningoencefalitis y hasta los lactantes con procesos severos en el curso de una neumonía grave. No es a este llanto al que se refiere la autora, es al niño que está bien de salud y llora en los horarios descritos.

Muchos pediatras y profesionales de la salud explican el llanto por los famosos gases en el tubo digestivo, mientras otros niegan su posible causa-efecto; se citan investigaciones donde han demostrado que, después de estar el niño llorando por horas y luego estar dormido, realizan un estudio radiológico del abdomen que pone de manifiesto mucha cantidad de aire en su tubo digestivo y, no obstante, los bebés duermen apaciblemente. Por eso es fundamental la vinculación que se logró después de muchos años entre los períodos de crecimiento rápido y el llanto excesivo del niño.

Otros hablan de madres inexpertas y ansiosas por los chillidos de sus bebés, ambientes con poca ayuda familiar y hasta de mamás necesitadas de tomar siestas, de descansar para resolver estas situaciones y disminuir esas crisis de llanto excesivo. Se emiten un conjunto de consejos útiles como: descanso para las madres, siestas, apoyo y ayuda de los familiares, levan-

tar al bebé de inmediato cuando empieza a llorar, arrullarlo y acariciarlo, subirlo en el hombro, pasearlo en su coche por fuera del hogar y muchas recomendaciones más, pero no ofrecerle un biberón de leche que agravará la situación, pues la sobre alimentación aumenta el llanto.

Brazelton describe que, como promedio, los niños lloran: 1.75 horas a las dos semanas de nacidos, 2.75 horas a las seis semanas y 3.75 horas por día a las 12 semanas. Esto se corresponde con los períodos de crecimiento rápido o crisis de la lactancia que se presentan a las dos semanas, a las seis semanas y a las 12 semanas. Para estas situaciones deben estar preparadas las madres y las familias, pues no es necesario introducir otra leche ya que, al demandar más el infante, se incrementa la cantidad de leche que la madre produce.

Correlación entre el llanto y los períodos de crecimiento rápido del niño

Cuando el niño llora no se le deben realizar movimientos vigorosos. La autora le ha denominado a ello “*abuelas batidoras*”, porque agitan al niño y esto empeora el llanto. Es necesario que lo cargue la persona que esté más tranquila, pues los bebés perciben los brazos tensos, así que recomiende: levántelo y arrúllelo, ofrézcale caricias suaves y háblele bajito. Si el niño no se calma, usted debe explorar posibles causas de llanto que no son las usuales, recuerde que puede estar muy arropado o tener frío.

Además de calor o frío, le recomiendo que explore si existe otra causa: sed, dolor, exceso de ropa o muy ceñida, una picada de insecto, una rozadura u otra causa, pero recuerde que se trata de niños sanos, que lloran en exceso en determinados períodos de tiempo. ¿Tomó la mamá mucho café, té, Coca cola, entre otras sustancias estimulantes?

El llanto del niño... No olviden: Mucha paciencia, mucha ternura, muchas caricias de mamá y papá.

...¿Hambre, frío, calor, dolor? Período de crecimiento rápido. Si muy probable dos semanas 6 semanas y 12 semanas (3 meses). Mejor sería:

- ¡Caricias y mimos en el regazo materno o brazos de papá!
- Mantener lactancia materna exclusiva a libre demanda y mucho amor, apego y armonía familiar.

***Dra. Eva Josefina Quinteros Fleites**

Doctora en Ciencias de la Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba (PhD).

Doctora en Medicina Universidad Central de Las Villas, Especialista de Primer Grado en Pediatría y Especialista de Segundo Grado en Pediatría. Magister en Atención Primaria de Salud.

Profesora Consultora y Titular de Pediatría que ha contribuido a la formación de médicos desde hace 50 años y a la formación de especialistas en Pediatría y en MGI en la Provincia Villa Clara. Se ha desarrollado como docente de Pediatría y más tarde de Medicina General en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. También ha realizado asesorías en varias provincias de Argentina desde hace 20 años y en la UNMdP en el ámbito de la nueva Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata.

Experiencia en docencia de post grados internacionales desde 1994 (25 años) “Nuevos enfoques y métodos en Atención Primaria de Salud”. Se ha destacado su labor en las áreas de promoción de salud, nutrición infantil, salud materno infantil, y lactancia materna

Profesora Universitaria, con vínculo estrecho en la formación y perfeccionamiento de los recursos humanos para implementar la Estrategia de Atención Primaria de Salud, como parte de la Renovación de esta estrategia para Las Américas.

Evaluadora de la primera carrera de Medicina de Cuba con la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del MES de Cuba en 2004 y en otras carreras en Cuba en Ciudad La Habana y Camaguey.

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA ATENCIÓN PERINATAL: ¿POR QUÉ SEGUIMOS RESISTIENDO?



LIC. MARIANELA BALANESI*

DRA. MARTINA CISNEROS**

DRA. GUADALUPE GARCIA MONLEZUN***

Sumario

A más de dos décadas del cambio de paradigma en la atención perinatal, siguen vigentes las resistencias a su implementación. En muchos casos, esto se transforma en una violación de derechos legal y específicamente reconocidos. Se analizan las causas de la resistencia en algunos profesionales, señalando el impacto de la cultura organizacional y la ausencia de políticas institucionales firmes que garanticen el ejercicio de estos derechos. Se reflexiona acerca de la existencia de una zona de libertad interior que cada profesional conserva, coherente con la ética de su profesión, el deber de comprometerse en velar por los derechos de los usuarios, y el impacto positivo de este tipo de actitudes en el bienestar y niveles de motivación de los propios profesionales.

“Lo cotidiano, como lo habitual, lo rutinario, lo banal, lo pequeño, lo indolente, lo que transita en la sombra, entre los que se desarrolla la vida humana, es donde tienen lugar los discursos y las prácticas del cuidar” (Foucault).

Introducción

El Modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF), inspirado en la iniciativa “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” (HAMN) creada por UNICEF-OMS, desarrollado desde

hace 38 años por el equipo de salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (HMIRS), e implementado en las Maternidades argentinas desde 1994, constituyó un nuevo paradigma en lo que respecta a la atención perinatal (1).

La evidencia científica respecto de sus beneficios es incuestionable. Paralelamente, la Ley de Parto Humanizado 25929 del año 2004, y su relativa reciente reglamentación a través del Decreto 2035/15 establecen claramente los derechos de las mujeres embarazadas y sus hijos durante el proceso de parto, internación conjunta o internación en áreas de cuidados intensivos neonatales. El modelo de MSyCF se anticipa a la legislación y recoge derechos fundamentales que le asisten a los padres durante uno de los momentos más significativos en la biografía personal y familiar como es el nacimiento de un hijo.

Además de su categoría de derecho, lo que obliga a su protección y habilita a los usuarios para reclamar su exigencia, los beneficios de la implementación del Modelo de MSyCF, se encuentran ampliamente reconocidos y cuentan con abundante evidencia científica. Cualquier intento de desconocimiento de la misma, debería ser considerado una negligencia, no obstante, se naturaliza. La cultura organizacional, a la cual nos referiremos más adelante, suele avalar estos comportamientos negligentes y violatorios de derechos.

Creemos que el desconocimiento y avallamiento de derechos básicos, impacta por supuesto en la calidad de la atención brindada. Por otra parte, y desde una mirada aún más amplia, sostenemos que este tipo de cuestiones profundizan el distress moral que a menudo inadvertidamente va socavando el bienestar de los profesionales de la salud al punto de impactar profundamente en sus niveles de motivación, generando malestar, desánimo, pérdida de interés y conformismo.

El círculo vicioso se instala entonces, a mayor insatisfacción, la calidad de la asistencia se empobrece.

El presente artículo tienen como objetivos las siguientes cuestiones:

- Describir algunas situaciones reiteradas que demuestran las resistencias a la implementación de un modelo inclusivo y protectorio de derechos en la instancia de atención prenatal, nacimiento e internación conjunta.
- Visibilizar las historias personales y el complejo contexto que subyace detrás de cada una de estas situaciones de restricciones indebidas de derechos vigentes.
- Analizar las probables causas que perpetúan la resistencia y proponer caminos alternativos para generar cambios graduales pero sostenibles a través del tiempo.

El individuo que se inserta en una institución, sabe, o de lo contrario aprende que los valores y los rasgos de los individuos que las componen, distan mucho de ser homogéneos. Este profesional, por lo general recién iniciando su recorrido, se va a tener que insertar dentro de una cultura organizacional. La misma determina ese modo de sentir y actuar al interior de la institución (2). Puede incluso, ser contraria o violatoria de derechos vigentes, no obstante, encontrarse naturalizada por su persistencia en el tiempo, costumbre y muy a menudo, por la comodidad de quienes llevan años haciendo lo mismo.

Creemos que es necesario anticipar la existencia de una brecha entre lo que se proclama y lo que se implementa al interior de los escenarios de atención de la salud. Personas altamente motivadas pueden padecer fuertes impactos negativos al advertir hasta que punto la cultura organizacional entra en colisión con los valores

personales, las aspiraciones y motivaciones profesionales, las mismas que, probablemente, hayan impulsado la elección de una profesión cuyas bases más profundas se asientan en valores de altruismo. De esta manera, no solo estamos enseñando a desarrollar un pensamiento crítico sino que se intentan aportar herramientas tendientes a aumentar la resiliencia previniendo el desgaste y distrés moral, preludio que anuncia por lo general, la instalación del síndrome de Burn-Out en el profesional de la salud.

La atención perinatal abarca las consultas pre-natales, el proceso de trabajo de parto, el parto, la recepción del recién nacido, la internación conjunta y, en caso de ser necesario, la internación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Describiremos en primer lugar, las resistencias encontradas al interior de los primeros cinco momentos, ya que entendemos que estos se integran lo que constituyen el nacimiento de un niño sano, escenario en el cual lo patológico debería dejar de tener el protagonismo que tradicionalmente se le asigna en el contexto de la atención sanitaria. Luego analizaremos las posibles causas y propondremos cursos de acción que favorezcan el ejercicio de derechos de los sujetos usuarios de nuestro sistema de salud, en la convicción de que los profesionales de salud tenemos la obligación ética de velar por su implementación y respeto.

Primer escenario: la atención prenatal

Situaciones:

-Laura tiene 23 años, trabaja en el puerto, es filetera y hoy es su día libre. Hace 4 meses que está en pareja, pero aun no ha dicho nada. En su entorno familiar hay consumo problemático de sustancias. Más allá del complejo contexto, ella desea tener al bebé.

Ha tomado un colectivo para llegar a la Sala. Como le habían dicho que los turnos se otorgaban por orden de llegada y que no se daban muchos por día, se levantó a las 5 AM. 5,50 hs estaba afuera del CAPS, esperando que se abra, en una mañana fría y ventosa de julio en Mar del Plata. A las 7:00 AM el CAPS abre sus puertas. Es el primer contacto de Laura en muchos años con el sistema de salud. El cuidado de su salud se venía postergando por distintas razones, así que se encuentra algo desorientado. Pide información, le dicen que se dirija a Obstetricia.

Golpea la puerta. Le abre un profesional que no se identifica. Mirando en dirección a la cola de embarazadas que esperan ser atendidas, le dice: *“La obstetra no está, y solo ella es la que da los turnos. Tenés que volver mañana a sacar turno”*. Laura se enoja, pero se queda callada. Prácticamente le cierran la puerta en la cara. Se vuelve a su casa pensando cual será su próximo día libre y deseando tener más suerte en su próximo intento, cuando su embarazo haya avanzado hacia la semana 16...

- Maira ha perdido dos embarazos deseados y planificados, con su pareja Diego. Tienen 37 y 39 años y están en pareja hace más de veinte años. Habían renunciado al deseo de ser padres cuando los sorprendió un embarazo inesperado. Ella tiene un retraso en su menstruación de más de un mes y el test casero le ha dado positivo.

Fueron juntos a la consulta, llenos de ilusiones pero también de miedos. Aún no ha revelado la noticia a la familia. Les dijeron que en la primera consulta les darían también la orden para realizarse la primera ecografía.

El CAPS al cual concurren está en remodelación, por lo cual, los consultorios se han improvisado en otros espacios. Un cartel en la puerta anuncia: *“Solo se admite el ingreso de la mujer embarazada. Disculpen las molestias”*. Diego disimula su desilusión y anima a Maira a que entre, deseándole suerte. Se queda en la sala de espera, nervioso y expectante.

Las dos situaciones presentadas a modo de ejemplo se repiten a diario en muchas instituciones. Aún cuando se encuentran a menudo naturalizados por esa cultura organizacional a la cual aludimos anteriormente, se traducen en lo contrario a lo pregonado por el Modelo de MSyCF. Y son, además, violatorias de derechos.

Un breve análisis de las dos situaciones, miradas desde el contexto institucional, ponen en evidencia algunos patrones comunes que tienden a reiterarse:

- Organización deficiente.
- Recursos humanos insuficientes y pobremente capacitados.
- Sueldos no acordes a las responsabilidades implicadas.
- Dificultades profundas para el trabajo en equipo.
- Bajos niveles de motivación por parte de

los profesionales.

- Infraestructura inadecuada.

Cada uno de estos déficits impacta en la calidad de la atención.

Ninguna de las siguientes recomendaciones vigentes para la atención humanizada y centrada en la familia durante el control prenatal se implementó en estos casos:

- Turnos programados, con ampliación de horarios matutinos y vespertinos
- Respeto por la privacidad de la mujer durante las consultas permitiéndole siempre ingresar acompañada por la persona de su confianza.
- Explicar dudas y responder preguntas.
- Brindar información sobre la ley de parto humanizado.
- Brindar contención y apoyo emocional a la mujer y la familia.
- Apoyo a la lactancia materna.
- Salas de espera amigables.

Cada una de estas recomendaciones apuntan al mismo objetivo: alentar e implementar el control prenatal precoz, periódico, completo y de amplia cobertura, *‘El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenidos, oportunidad y diferenciado acorde al riesgo contribuye positivamente a la salud familiar y es un claro ejemplo de medicina preventiva’* (3), requisito indispensable para evaluar el riesgo perinatal y asegurar las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE).

Una oportunidad perdida por negligencia, puede llevar a un nacimiento con complicaciones prevenibles. El costo lo paga el recién nacido, la madre, la familia, la sociedad. Y cuesta dinero. Mucho más dinero que el que se requiere invertir para solucionar los problemas que aparecen como obstáculos para la implementación de una adecuada y eficiente atención prenatal.

Segundo escenario: Atención del trabajo de parto y parto. Internación conjunta madre/hijo

Situaciones:

- Jorge es obstetra y trabaja hace más de 20 años en una concurrida Maternidad de la Provincia de Buenos Aires. Su queja se hace oír a todo quien tenga deseo de escucharle. Está

cansado. Realiza guardias de 24 horas más la 'post-guardia' del día siguiente. Atiende partos en simultáneo. Resuelve urgencias sin contar con el recurso humano ni material que necesita. Le queda poco tiempo para jubilarse. No está satisfecho con su trabajo y hace años que perdió la motivación por su trabajo. Además de estas condiciones, y según sus propias palabras, tiene que enfrentarse a diario a las exigencias de las pacientes que *'nos dicen como tenemos que trabajar, que no quieren episiotomía, que quieren caminar y encima si no las escuchas te pueden hacer juicio...'*

- Miriam tiene 34 años. Acaba de dar a luz a su primer bebé, Juan, que pesó 4300 gramos, con lo cual le programaron cesárea por desproporción cefalo-pélvica. Estaba asustada antes de entrar, era su primera intervención quirúrgica. Su pareja, Marcos, no pudo entrar a presenciar el nacimiento, según le informaron para prevenir el contagio de infecciones al bebé. Aunque el había leído que tenía derecho a presenciar el nacimiento, no tenía muy claro si esto incluía el nacimiento por cesárea. Le pareció lógico el argumento de la posibilidad de infecciones, con lo cual se quedó callado, esperando el nacimiento.

La cesárea estaba programada para las 8:00 am. Hubo una urgencia en el quirófano, con lo cual Miriam entró media hora más tarde. Su bebé, Franco, fue trasladado al 'cunero' de la internación conjunta mientras ella espera en una camilla incómoda y con mucho frío, que el camillero venga a buscarla para trasladarla a dicho servicio. Está ansiosa por tener a su bebé en brazos.

Mientras tanto, Marcos pudo advertir que el bebé que pasaba apresuradamente en la cuna era su hijo, así que pide le permitan estar con su bebé. Así lo hacen. Veinte minutos después, llega Miriam a la internación conjunta. Sacan a Marcos del cuarto para preparar a la madre. Logran reunirse los tres dos horas y media después de transcurrido el nacimiento de Juan, quien a esta altura, ya fue alimentado con 10 ml. de leche de fórmula ya que el neonatólogo de turno determinó que con ese peso el bebé corría riesgo de hipoglucemia. El primer intento de colocar al pecho a Franco es un fracaso. A Miriam le duele la cesárea, la vía periférica que tenía pasando analgesia se le infltró y tardan casi 45 minutos en venir a recolocársela. Cuando

la enfermera finalmente llega, encuentra a Miriam llorando amargamente ya que no logra que Juan se prenda a la teta y le duele muchísimo la cesárea.

- Karen, de 17 años llora con mucha angustia. Su bebe tiene un día de vida, intenta ponerlo al pecho pero no consigue lograr la prendida, hace más de una hora la enfermera del piso ha subido a quirófano a asistir un par de cesáreas y aun no ha vuelto. La madre de la cama de al lado le dice que lo mejor es darle un biberón. Ella está sola, desconcertada. Es su primer bebé y no han dejado que su pareja permanezca acompañándola.

Analicemos una vez más los patrones comunes presentes en estas situaciones:

- Recursos humanos desgastados y desmotivados, inadecuadamente valorados, con salarios insuficientes y pluri-empleo, deficientes en cantidad recomendada para asegurar una atención de calidad.
- Gestión deficiente (direcciones/jefaturas/equipo), ausencia de sentimiento de trabajo en equipo y liderazgos positivos.
- Percepción del legítimo reclamo de los usuarios como abuso o amenaza.
- Ausencia total o implementación deficiente de gran parte de las prácticas recomendadas con beneficios ampliamente probados: presencia de un acompañante conforme el deseo de la mujer durante el trabajo de parto y parto, implementación del Contacto piel a piel tras el nacimiento (aún en los nacimientos por cesáreas esta recomendación podría adaptarse), fomento del vínculo sin demoras tras el nacimiento, fomento de la lactancia materna dentro de la primera hora de vida, contención emocional a la familia y la madre tras el nacimiento (4-5-6)
- Atención fragmentada, mala comunicación, mensajes contradictorios entre los diferentes actores intervinientes.

Consecuencias:

- Nacimientos medicalizados, vínculos innecesariamente interrumpidos, consecuencia causa efecto difícil de cuantificar (aunque varios estudios ya prueban el

impacto en la instalación precoz eficaz de la lactancia, duración, y algunas consecuencias potencialmente negativas en el apego en situaciones complejas) Contexto desfavorable para el inicio de una lactancia eficaz.

- Pérdida de oportunidades para brindar información adecuada y pautas de cuidado y de alarma claras para asegurar el bienestar del binomio tras el alta, detectar riesgo social (abuso de sustancias, violencia, deserción escolar, trastornos de salud mental, etc.)

¿Por qué seguimos resistiendo? Análisis breve

Han pasado ya 26 años desde que se empezaran a pregonar los beneficios de la implementación del Modelo de MSyCF, y 16 años desde la sanción de la Ley de Parto Humanizado. La evidencia científica es ahora abrumadora. Nadie puede a esta altura cuestionar los beneficios de implementar el COPAP tras un nacimiento sin complicaciones o de favorecer la presencia de un acompañante –si la madre lo desea– al momento del nacimiento y durante la internación conjunta. Permitir y favorecer que las familias recuperen el protagonismo que el nacimiento medicalizado ha pasado a ocupar, dista de ser una realidad uniforme para depender de criterios ‘profesional-dependientes’, lo que a su vez impide que los usuarios se empoderen y reclamen la efectiva implementación de los derechos que les asisten.

Desde nuestra mirada, las resistencias obedecen a diferentes razones. Si bien es cierto que para sostener todas las prácticas que debieran implementarse para transformar nuestras Maternidades en espacios que aseguren y favorezcan el ejercicio de derechos, se requiere de una política institucional que la avale, no es menos cierto que los profesionales de la salud no podemos ni debemos permanecer indiferentes frente a los recurrentes abusos de derechos que se presencian en nuestra praxis cotidiana.

“Volviendo al punto de vista del usuario podemos decir que, en general, éste reclama no de la falta de conocimiento tecnológico para su atención, sino de la falta de interés y de responsabilidad de los diferentes servicios en torno de sí y de su problema. Como regla, los usuarios se sienten inseguros, desinformados, desampara-

dos, desprotegidos, despreciados, no respetados”. (7)

Quienes se resisten, lo hacen a menudo fuertemente. Y resisten a quienes resisten. Es decir, no permiten que se cambien los procesos de trabajo instalados con justificaciones absurdas. A quien cuestiona se lo silencia y se lo somete al poder de jefaturas que por toda respuesta esbozan el conocido y mas absurdo de los argumentos: *‘acá esto siempre se hizo así’*.

Una década y media después de la sanción de una ley de parto humanizado, -a esta altura ya no podría alegarse desconocimiento-, aún persiste cierta sutil tendencia a trasladar en forma directa o indirecta la responsabilidad hacia los propios sujetos que en situación de extrema vulnerabilidad, demandan nuestra atención. Si la pusieramos en palabras, se materializa en aquellas frases que escuchamos a diario en nuestros servicios: *“...tienen hijos para cobrar los planes”*.... *“...deberían obligarlas a no tener más hijos”* *“...esperan que el Estado todo lo resuelva”* *“...son unas ignorantes”* *“...no se cuidan porque no quieren”* y un largo e irrespetuoso etcétera.

Como decíamos antes, la solución de raíz a esta compleja problemática requiere políticas institucionales que debieran implementarse previo diagnóstico de la cultura organizacional, refuerzos en la capacitación a los profesionales, adecuada ratio médico/enfermería/paciente, sueldos acordes y un largo etcétera vinculado a políticas de salud que, por lo general, exceden el ámbito de posibilidad de acción de quienes acceden a una residencia o se insertan como médicos de planta de cualquier institución.

No escapa a nuestra propuesta el conocimiento de que muchos de los contextos sanitarios están cruzados por variables que merman la compasión en los profesionales de la salud, incluyendo distrés moral (Dzeng et al., 2016), presiones económicas (Borgstrom & Walter, 2015), culturas organizacionales tóxicas (deZulueta, 2015; Cole-King & Gilbert, 2011), sobrecarga de trabajo e inseguridad laboral (Sinclair et al., 2017; Mota et al., 2016).

Sin embargo, queda esa zona de libertad, que es a la cual queremos apelar. Es precisamente en esa zona de libertad interior, de poder elegir un comportamiento ético, respetuoso de la dignidad del otro, donde reside un poder que no todos alcanzamos a vislumbrar. Y es dentro de ese mismo espacio, donde podremos evitar, ya

desde el inicio de nuestra formación caer en el perverso círculo vicioso que conduce al distrés moral: es decir, realizar repetidamente acciones que sabemos no son las que corresponden o no realizar acciones que sabemos con certeza, son las que debíamos realizar. Esto tiene un claro impacto. Tal como se lo ha definido, el distrés moral es esa angustia *“que aparece cuando los individuos tienen criterios morales claros con respecto al camino a seguir pero no pueden hacerlo debido a impedimentos externos, ya sean institucionales, sociales o contextuales. El resultado final es el impacto negativo en la integridad personal, el bienestar físico y emocional, la satisfacción laboral y el cuidado del paciente.”* (8)

Recuperar lo esencial del trato, que es la relación terapéutica. El vínculo terapéutico es parte integral de la intervención y afecta su resultado, y esto es cierto no solo en psicología sino en todo el espectro de intervenciones en salud (CITA). Como bien se ha afirmado: *‘la compasión no se opone al autocuidado, al contrario: al deshumanizar nuestro trato a otro deshumanizamos una parte de nosotros mismos. Y si nos deshumanizamos crónicamente, nuestra salud se ve afectada’*.

¿Qué hacer entonces?

Puede que apelemos a respuestas abiertas, porque aquí entrará en juego la creatividad, el trabajo en equipo, la resiliencia, la motivación personal. Siempre contaremos con la posibilidad, al decir de E. Merhy, de poner en juego la utilización de todas nuestras herramientas de *“tecnología blanda”* (9) que componen nuestro maletín.

Es necesario interpelarnos, repreguntarnos, repensar cada uno de nuestros procesos de trabajo, en una búsqueda incesante de estrategias eficaces que optimicen el potencial de salud de las madres y sus bebés.

Lo que Sí podemos hacer:

Acciones sencillas, individuales, libradas a nuestra entera libertad: nombrar a la madre y al niño por su nombre. Evitar *‘mamá, mamita, madrecita’*. Brindar tiempo de calidad. Escucha activa, mirar a los ojos. Lenguaje verbal que revele interés. Mantener el asombro frente al milagro de cada nacimiento y cada bebé que en su instinto de supervivencia, busca el pecho ma-

terno por primera vez. Cuidar la intimidad de las mujeres, en todo momento. Pedir permiso antes de intervenir sobre el recién nacido: desvestirlo, mirar el cordón, auscultarlo, tomarle la temperatura. Indagar sobre la lactancia con interés en anticipar problemas y acompañar en el proceso.

Otras acciones:

- Valorar e implementar, paso a paso, caso por caso, aquellas intervenciones de bajo costo y gran impacto, como el contacto piel a piel desde el nacimiento, la lactancia materna, el trato respetuoso y empático. El trato compasivo es un imperativo ético que no se aprende en ninguna facultad. De la misma manera que NINGUNA circunstancia externa justifica el maltrato a los usuarios. Estos deben quedar por fuera de cualquier legítimo reclamo que podamos emprender para mejorar nuestras condiciones de trabajo, pero nunca el impacto debiera recaer sobre los más vulnerables, es decir, los sujetos de nuestra atención.
- Buscar aliados para el cambio y aprender a pasar de los esfuerzos solitarios e individuales a un modelo colectivo y solidario.
- Incorporar a las familias como aliados y no como enemigos. Empoderarlos. Orientarlos para que sean ellos mismos quienes reclamen que sus derechos sean protegidos (mandarlos a golpear la puerta de la Dirección: suele tener un poder mágico)
- Proteger y cuidar el nacimiento de nuestros niños de una forma amorosa y empática. Tomar consciencia del enorme privilegio que implica poder presenciar este acto tan significativo en la biografía de todo ser humano, y que no es un acto aislado o momentáneo, ni una relación pasajera. El impacto de nuestras acciones y omisiones dejará una huella permanente en cada familia, ante el inicio de cada vida única e irrepetible. En definitiva, en esta simple verdad se sustenta el principio de dignidad humana, pilar y origen de todos los derechos humanos.

Conclusión

A más de dos décadas del cambio de paradigma en la atención perinatal siguen vigentes las resistencias a su implementación. En muchos ca-

sos, esto se transforma en una violación de derechos legal y específicamente reconocidos (Ley de Parto Humanizado y Dec. Reg. 2035/2015).

Las causas por las cuales estas resistencias se siguen produciendo son muy complejas y para implementar cambios duraderos se requieren cambios en la política sanitaria, que invierta recursos humanos y materiales (más personal, más capacitación, mejor infraestructura). El costo-beneficio de este tipo de intervenciones, se encuentra ampliamente demostrado.

Este tipo de decisiones macro incumben a los diferentes niveles de gestión, no obstante, defendemos y afirmamos que aún en el complejo contexto socio-sanitario, los profesionales mantienen el imperativo ético y legal de velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

‘Cuando los seres humanos (ya sea en el rol de profesionales, pacientes, técnicos, gestores, administrativos, familiares) nos sentimos vistos y respetados, cuando nos sentimos seguros (en vez de amenazados), contentos (en vez de frustrados) y conectados (en vez de aislados), salen a la luz nuestros mejores recursos: los profesionales trabajan alineados con su vocación y con su mejor capacidad técnica y los pacientes se encuentran en el mejor estado que pueden estar dentro de los límites de su diagnóstico’ (10).

Creemos que existe una zona de libertad cuyo potencial no se optimiza. Estos pequeños cambios actitudinales, el cuidado de lo invisible, que se sostiene y se replica, impactará en la calidad de la atención, sin dudas. Y como la atención se establece en el contexto de una relación terapéutica, los beneficiarios no serán solo los usuarios.

En definitiva, y trascendiendo los roles, de un lado o del otro de dicha relación, lo que se produce siempre es el encuentro entre dos personas. Poder enriquecerlo es una habilidad que podemos y debemos desarrollar.

Referencias bibliográficas

1. Largaia, M, González MA, Solana C, Basualdo NM, Di Pietrantonio E, et al. *Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque intercultural*. 2012. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Buenos Aires, Argentina.
2. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) – Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). *ABC de la MSCF. Manual para el Diagnóstico de la Cultura Organizacional*. Buenos Aires, 2015
3. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud de la Nación. *Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal*. 2013. Buenos Aires. Argentina.
4. Soto Conti, C. Primera hora de vida. Una ventana de oro. *Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá* 2018;3(3), pp. 168-178
5. World Health Organization. *Post partum care of the mother and newborn: a practical guide*. Geneva: World Health Organization; 1998.
6. Darmstadt G, Bhutta Z, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L. Evidence-based, cost-effective interventions: how many newborn babies can we save? *Lancet* 2005; 365(9463): 977-988.
7. Merhy, E. E.) *Salud: cartografía del trabajo vivo*. 2006. Argentina, Buenos Aires: Lugar Editorial.
8. Prentice T, Gillam L, Davis P, Janvier A. The use and misuse of moral distress in neonatology. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2018 Feb;23(1):39-43. doi: 10.1016/j.siny.2017.09.007. Epub 2017 Sep 28
9. Merhy E. *Op cit*.
10. Bedregal P, Lermenda V, Brito Pons G. La compasión: clave en la renovación de la atención en salud. *Ars Médica. Revista de ciencias médicas*

*Lic. Marianela Balanesi

Abogada (UNMdP). Lic. Esp. en Enfermería Neonatal (UNMdP). Miembro del Comité de Bioética del HIGA-HIEMI Mar del Plata, Docente de la Cátedra Salud del Niño, Niña y Adolescente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

**Dra. Martina Cisneros

Médico Pediatra (UNLP), Neonatóloga. Docente de la Cátedra Salud del Niño, Niña y Adolescente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

***Dra. Guadalupe García Monlezun

Médico pediatra (UNLP), Docente de la Cátedra Salud del Niño, Niña y Adolescente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

AFECCIONES DERMATOLÓGICAS PEDIÁTRICAS MÁS FRECUENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS



DRA. CINTIA ESQUIVEL*

DRA. DANIELA PEREYRA BETTONI**

DRA. CLAUDIA CHIAVAZZA***

DRA. IANINA MASSIMO ****

Revisora

Sumario

Este capítulo se basa en el análisis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades dermatológicas más frecuentes diagnosticadas en niños dentro del rango de edad de 1 mes a 13 años inclusive, evaluados en consultorios externos pediátricos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega- Moreno en desde enero a diciembre del 2019.

Introducción

Se realizó un trabajo retrospectivo sobre la base de datos del hospital, cuyo resultado fue:

- Se atendieron en el año 12.513 pacientes.
- De ellos 10.929 fueron no dermatológicos y 1.584 dermatológicos (14,49%).
- De los dermatológicos, las patológicas fueron:
 - Infecciones de piel y partes blandas 31% (488)
 - Dermatitis atópica 20% (322)
 - Exantemáticas 19% (298)
 - Escabiosis 6% (102)
 - Urticaria 6% (88)
 - Resto de las enfermedades fueron dermatitis de contacto 7% (106), estomatitis 3% (42), prurigo 2% (37), picadura de insectos 2% (33), herpes 1% (22), Tiña 1% (21), balanopostitis 1% (15), mu-

guet 1% (11), verrugas 1% (10), Purpuras 0% (5), moluscos contagiosos 0% (2), onfalitis 0% (1), sudamina 0% (1).

A continuación, se describirán las patologías más frecuentes exceptuando enfermedades exantemáticas ya que merecen un capítulo aparte.

Infección de piel y partes blandas (IPPB)

La IPPB es la causa más frecuente de consulta. El *Staphylococcus aureus* y el *Streptococcus pyogenes* (SBHGB) son los principales agentes etiológicos.

La emergencia, en los últimos años, de cepas de *S. aureus* meticilino resistentes provenientes de la comunidad y *S. pyogenes* resistentes a eritromicina plantea controversias en la elección del tratamiento empírico inicial.

De acuerdo con el compartimiento de la piel involucrada se clasifican en impétigo y foliculitis (epidermis), erisipela y forúnculo (epidermis y dermis), celulitis (celular subcutáneo) y celulitis necrotizantes (celular subcutáneo hasta fascia muscular)

Pueden ser primarias (se asientan sobre piel sana) o secundarias (se asientan sobre piel enferma: quemadura, eczema, psoriasis).

Epidemiología

Los microorganismos más frecuentemente aislados de IPPB durante el período 2009-2010 en nuestro país fueron:

- Menores de 12 meses: *S. aureus* (85,4%); SBHGA (3,4%); *Proteus mirabilis* (2%) y *Pseudomona auriginosa* (2%).

- De 1 a 5 años: *S. aureus* (84%); SBHGA (3%) y *Haemophilus influenzae* tipo B (HiB) (2%).

- De 6 a 15 años: *S. aureus* (76,4%) y SBHGA (5,8%).

En diferentes estudios multicéntricos nacionales realizados sobre infecciones producidas por *S. aureus* proveniente de la comunidad, el porcentaje de meticilino resistencia osciló entre el 42% y el 60-70%.

Clínica

IMPÉTIGO: suele ubicarse en zonas expuestas como extremidades, cara, y periorificiales. Se clasifica en:

- No ampollar o no bulloso, es el más común, se caracteriza por pápulas y vesículas rodeadas de eritema que luego se transforman en pústulas que se rompen formando costras.

- Buloso o ampollar, causado por una toxina exfoliativa A del *S. Aureus*, son ampollas flácidas con líquido amarillo y luego turbio que se rompen dejando una corteza marrón (Figura 1).

Las complicaciones son raras (celulitis, adenitis, artritis, osteomielitis, sepsis) (Figura 2).

ECTIMA: es una forma ulcerosa de impétigo, consiste en úlceras perforadas cubiertas con costra amarillenta rodeadas de márgenes violáceos elevados.

Es importante hacer diagnóstico diferencial con el ectima gangrenoso que es una afección potencialmente letal causada por *Pseudomona Aeruginosa*; se trata de máculas eritematosas o purpúricas indoloras que evolucionan rápidamente en vesículas o ampollas hemorrágicas que posteriormente se rompen para dejar una úlcera con escara negra necrótica (Figura 3).

CELULITIS: se observa eritema, edema y calor, pueden verse petequias y/o hemorragias en la piel eritematosa y aparecer ampollas superficiales. El sitio más frecuente son extremidades inferiores.

Puede haber manifestaciones sistémicas como fiebre y adenopatías regionales.

Complicaciones: bacteriemia, endocarditis, artritis séptica u osteomielitis, infección metastásica, sepsis y síndrome de shock toxico (Figura 4).



FIGURA 1. Impétigo no ampollar



FIGURA 2. Impétigo ampollar



FIGURA 3. Ectima



FIGURA 4. Celulitis



FIGURA 5. Erisipela



FIGURA 6. Absceso



FIGURA 7. Forúnculo



FIGURA 8. Ántrax

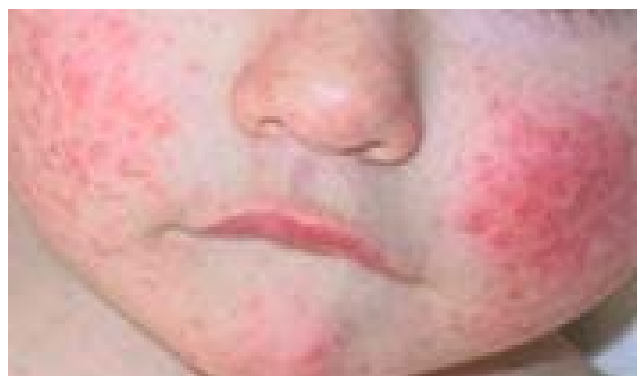


FIGURA 9, 10, 11. Dermatitis atópica

ERISPELA: Es una placa roja brillante, indurada (piel de naranja), de bordes nítidos, dolorosa, con rápida extensión y linfedema regional. Pueden presentar flictenas y bullas sobre la placa. Suele ser secundaria a una lesión. Se localiza principalmente en miembros inferiores y forma unilateral (Figura 5). Se acompaña de adenomegalias satélites y síntomas sistémicos.

Complicaciones: raramente.

ABSCESO: se presenta como una acumulación de pus dentro de la dermis o el espacio subcutáneo. Consiste en nódulo eritematoso, doloroso, fluctuante, con o sin celulitis circundante. No suele presentar síntomas sistémicos (Figura 6).

FORÚNCULO: es un absceso cutáneo del folículo piloso. Áreas comunes donde se presenta parte posterior del cuello, cara, axilas y nalgas (Figura 7). Carbúnculo o ántrax es una placa caliente y dolorosa que se diferencia por comprometer varios folículos pilosos (Figura 8).

Diagnóstico

Principalmente clínico. Los abscesos pasibles de drenaje deben someterse a incisión y drenaje, no es necesario el cultivo en pacientes sanos. No se requiere laboratorio para infecciones no complicadas.

Puede observarse leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda en pacientes con afectación sistémica.

El cultivo de material y HMCx2 se realiza en:

- ✓ Celulitis extensa
- ✓ Signos sistémicos
- ✓ Recurrencias o lesiones múltiples
- ✓ Fracaso de la terapia antibiótica inicial
- ✓ Extremos de edad
- ✓ Comorbilidades

Tratamiento

Los principales agentes etiológicos son *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes* por lo tanto hacia ellos debe dirigirse la antibioterapia empírica inicial. Sin embargo, dada la alta incidencia de cepas resistentes es importante considerar los siguientes aspectos para su correcto manejo:

- ✓ Historia de contacto con animales, viajes, etc.;
- ✓ Antecedentes o presencia de infecciones en contactos familiares;
- ✓ Estado clínico e inmunológico del huésped;
- ✓ Síntomas del paciente;

- ✓ Apariencia general del sitio de infección;
- ✓ Agentes infecciosos más frecuentes y sus patrones de sensibilidad antibiótica.
- ✓ En los casos más leves y con pocas lesiones se puede iniciar con tratamiento tópico. Mupirocina o ácido fusídico 3 veces al día por 7 días.
- ✓ En el resto de los casos se indica terapia oral iniciando empíricamente
- ✓ Cefalexina 50 a 100mg/kg/día 4 veces al día por 10 días,
- ✓ Alternativa amoxicilina + ac. Clavulánico 40mg/kg/día o eritromicina 50mg/kg/día por 7 a 10 días.
- ✓ En casos de resistencias se indica clindamicina 30mg/kg/día o trimetoprima-sulfametoxazol 10 mg/kg/día o doxiciclina.

Dermatitis atópica

Enfermedad inflamatoria crónica que cursa con brotes y remisiones. Caracterizado por sequedad de la piel y prurito o picazón.

Los términos dermatitis atópica y eccema se suelen usar como sinónimo.

Se clasifica en leve, moderada y grave pero la mayoría evoluciona favorablemente.

Se asocia con un nivel sérico elevado de inmunoglobulina E y un historial personal o familiar de atopia, que describe un grupo de trastornos que incluyen eccema, asma y rinitis alérgica. Aunque la sensibilización a los alérgenos ambientales o alimentarios está claramente asociada con el fenotipo de dermatitis atópica, no parece ser un factor causal, pero puede ser un factor contribuyente en un subgrupo de pacientes con enfermedad grave.

Epidemiología

Afecta a todas las razas, frecuente en niños, sin distinción de sexo, y según diferentes estadísticas entre el 5 y el 15% de la población la presentan. En el 90% de los casos se manifiesta antes de los 5 años de edad.

Clínica

Los signos cardinales de la dermatitis atópica son la piel seca y el prurito severo, generando inflamación y aparición de vesículas superficiales que se rompen fácilmente, cuya exudación genera costras melicéricas.

Las manifestaciones clínicas se diferencian según la edad:

En bebés y niños pequeños (de cero a dos

años), generalmente se presenta con lesiones pruriginosas, rojas, escamosas y costras en las superficies extensoras y las mejillas o el cuero cabelludo, respetando el área del pañal. Las lesiones agudas pueden incluir vesículas, y puede haber exudados serosos y costras en casos severos (Figura 9).

En niños mayores y adolescentes (de 2 a 16 años), se caracteriza por una menor exudación y, a menudo, muestra placas liquenificadas en zonas de flexión, especialmente antecubital y hueco poplíteo, muñecas, los tobillos y el cuello. Los lados del cuello pueden mostrar una pigmentación reticulada, el llamado “cuello sucio atópico”(Figura 9).

En adultos, la dermatitis atópica está considerablemente más localizada y liquenificada. Las áreas involucradas son en la mayoría de los casos las flexiones de la piel. Con menos frecuencia, puede afectar la cara, el cuello o las manos (Figura 9).

Características asociadas

Pueden presentar estigmas atópicos considerados como criterios diagnósticos menores, que incluyen palidez centrofacial, dermatografismo blanco, queratosis pilaris, hiperlinealidad palmar, pitiriasis alba, oscurecimiento periorbital y pliegues infraorbitales de Dennie-Morgan, adelgazamiento o ausencia de la porción lateral de las cejas (signo de Hertoghe), fisuras infraauriculares y retroauriculares, y eccema del pezón.

Complicaciones

Surgen como consecuencias de las alteraciones de la función de barrera cutánea y de las alteraciones inmunológicas humorales y celulares que favorecen las infecciones bacterianas y virales. Las infecciones bacterianas son las más comunes y se pueden producir por *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus b* hemolítico del grupo A, ya sea en forma aislada o combinada. Las infecciones virales se manifiestan con herpes simple diseminado, (erupción variceliforme de Kaposi o eczema herpético).

Diagnósticos diferenciales

Dermatitis seborreica: Las escamas son amarillentas y untuosas. Se presenta desde los 15 días de vida hasta los 3 a 6 meses de edad. Afecta cuero cabelludo, zona centrofacial y caudal. No pruriginosa.

Dermatitis de contacto irritativa: Lesiones, circunscriptas, vinculables a un agente irritante

primario. Ej.: dermatitis por saliva y dermatitis del pañal.

Dermatitis de contacto alérgica: Es poco frecuente en niños. Puede ser por níquel o cromo o tatuajes con henna.

Enfermedades eritematoescamosas: Psoriasis, pitiriasis rosada y pitiriasis rubra pilaris.

Ectoparasitosis: Sarna eczematizada. Lesiones pápulo-vesiculosas, pruriginosa. Suele estar afectado más de un miembro de la familia.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico y se basa en criterios mayores y menores propuestos por Hannifin y Rajka (Tabla 1). La biopsia de piel y las pruebas de laboratorio, incluidos los niveles de IgE, no se usan de forma rutinaria en la evaluación de pacientes con sospecha de dermatitis atópica y no se recomiendan.

Tratamiento

Según el Consenso Nacional de Dermatitis Atópica 2013 de la SAP, el enfoque terapéutico debe comprender dos aspectos:

Tratamiento reactivo: El manejo del brote.

Tratamiento proactivo: Las medidas generales para prevenirlo o que sea menos grave.

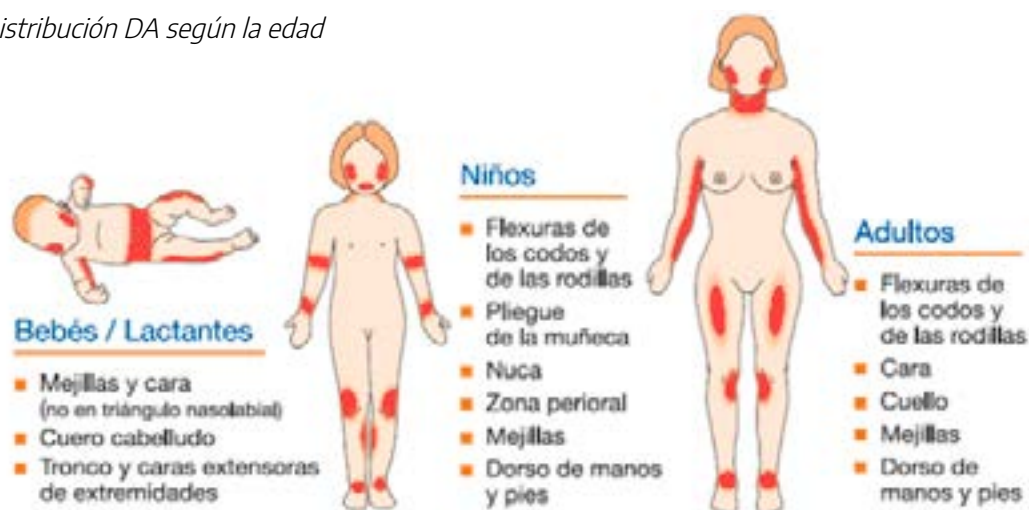
El cuidado proactivo comprende: Cuidados e hidratación de la piel.

Evitar sustancias irritantes en contacto con la piel, como perfumes, espuma de baño y toallas

CRITERIOS MAYORES	CRITERIOS MENORES
Prurito	Xerosis generalizada
Localización típica de las lesiones	Hiperlinealidad palmo-plantar
Aspecto o morfología típica	Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan
Cronicidad	Palidez facial
Recurrencia de los síntomas	Oscurecimiento periorbital
Antecedentes familiares o personales de atopia	Rinitis Queratocono
	Conjuntivitis
	Dermatitis inespecíficas de manos y pies
	Catarata subcapsular
	Ictiosis
	queratosis pilar

TABLA 1. Criterios de Hanifin y Rajka

Figura 12. Distribución DA según la edad



de limpieza perfumadas o con antisépticos.

El baño templado (27-30 °C) y breve, con productos de higiene no irritantes, de pH similar al de la piel y con efecto humectante.

Los emolientes son la base del tratamiento de mantenimiento; actúan mejorando la función de barrera de la piel y ejercen un efecto ahorrador de corticoides.

Alimentación No se recomienda el uso de dietas de exclusión.

Programas educativos educación de los padres de los pacientes acerca de la enfermedad y el manejo general para favorecer la adherencia al tratamiento y la mejoría del paciente a través de equipos multidisciplinarios.

Tratamiento reactivo:

Corticoides tópicos la primera línea de tratamiento para el brote de DA. La elección del corticoide y el tipo de vehículo va a depender del área afectada, la edad del paciente y el estado de la dermatosis.

Inhibidores de la calcineurina son drogas de segunda línea en el tratamiento de la DA, que se utilizan a corto o a largo plazo de manera intermitente.

Tratamiento antimicrobiano Las infecciones cutáneas bacterianas o virales contribuyen al empeoramiento de la DA.

Terapia sistémica únicamente en pacientes con enfermedad grave que no responde a otros tratamientos. Las drogas más utilizadas son los glucocorticoides sistémicos, la ciclosporina A, la azatioprina, el metotrexate. Aun esta en estudio el uso de agentes biológicos anti-TNF alfa (infliximab y etanercept) y antiIgE (omalizumab y mepolizumab).



FIGURA 13 Y 14. Urticaria

Urticaria

Lesiones cutáneas generalmente eritematosas, con centro más pálido, edematosas y pruriginosas, vitropresión positiva. Son de localización, forma y tamaño variables, y pueden persistir minutos, días o semanas.

La lesión típica es el “habón” o “roncha”, que migra en horas.

Las lesiones se limitan a la dermis superior.

En el 50% de los casos suele asociarse a angioedema, que es una inflamación más profunda en la piel. Puede dispararse por virus, reacciones alérgicas a alimentos y aditivos alimentarios, contacto con sustancias químicas e irritantes o estímulos físicos pero en su mayoría la causa específica no puede ser identificada.

Se clasifica según el tiempo de aparición:

Aguda si la urticaria/angioedema dura menos de 6 semanas,

Crónica, si persiste más tiempo

Recidivante, si los episodios de urticaria duran menos que los intervalos asintomáticos.

Según la causa:

Urticaria física: u. por frío (contacto)

u. por presión retardada

u. por calor (contacto)

- u. solar
- u. facticia
- u. vibratoria
- Otros desórdenes urticarianos: u. acuagénica
- u. colinérgica
- u. por contacto
- u. inducida por ejercicio

Epidemiología

Es un trastorno común en pediatría, con una prevalencia de aproximadamente el 20 por ciento en la población general.

Patogenia

No está completamente aclarada. La urticaria se produce por la estimulación y degranulación de los mastocitos que, a través de mecanismos inmunológicos y no inmunológicos, liberan diferentes mediadores, entre los que destaca la histamina, en respuesta a ciertos alimentos, fármacos, picaduras de insectos, estímulos físicos, etc.

La liberación de estos mediadores desde las células cutáneas inflamatorias conduce, por una parte, a un incremento de la permeabilidad vascular produciendo el típico habón y por otra a una estimulación del tejido neuronal que origina, tanto una dilatación vascular y la consecuente respuesta eritematosa, como el prurito.

Las lesiones pueden ser redondas, ovaladas

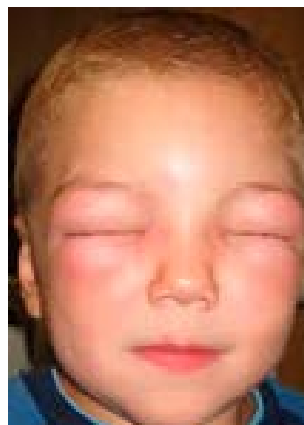


FIGURA 15. Angioedema



FIGURA 16 y 17. Escabiosis



FIGURA 18. Sarna noruega

ACTIVACIÓN INMUNOLÓGICA

Tipo I (mediada por IgE Histamina)

- Medicamentos
- Látex
- Picadura de insectos
- Aeroalergenos

Tipo II (activación del complemento mediada por mecanismos citotóxicos)

- Productos sanguíneos

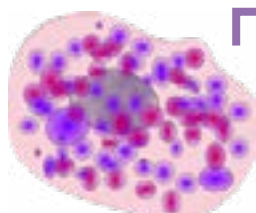
Tipo III (activación del complemento mediada por inmunocomplejos)

- Infecciones
- Enf. vasculares del colágeno
- Medicaciones (enf. del suero)

Tipo IV (hipersensibilidad celular retardada)

- Urticaria por contacto

MASTOCITO



DEGRANULACIÓN

URTICARIA/ ANGIOEDEMA

ACTIVACIÓN NO INMUNOLÓGICA

Acción directa en el mastocito

- Medios de radiocontraste
- Opiáceos
- Cumarínicos, antibióticos polianiónicos
- Acción del metabolismo del ácido araquidónico
- Aspirina y otros AINES
- Colorantes y conservantes

Activación del complemento (sin complejos antígeno-anticuerpo)

- Angioedema hereditario
- Depleción del inhibidor de C1 esterasa
- Productos sanguíneos

GRAFICO 1. Etiopatogenia de Urticaria

o serpiginosas y su tamaño varía de menos de 1 centímetro a varios centímetros de diámetro. Pican intensamente. El prurito puede interrumpir el trabajo, la escuela o el sueño.

Los síntomas a menudo parecen más graves por la noche.

Las lesiones individuales son transitorias, generalmente aparecen y se agrandan en el transcurso de minutos a horas y luego desaparecen en 24 horas.

Las lesiones pueden fusionarse a medida que se agrandan.

Las lesiones de urticaria normalmente no son dolorosas y se resuelven sin dejar marcas equimóticas residuales en la piel, a menos que haya un trauma por rascarse.

Cualquier área del cuerpo puede verse afectada.

El angioedema, cuando se asocia con la urticaria, generalmente afecta la cara y los labios, las extremidades y / o los genitales.

Diagnóstico

Es muy importante hacer una historia clínica completa y una exploración física detallada (descartar enfermedad sistémica), averiguar las causas, las más frecuentes (infección, alimentos y medicamentos), es difícil identificar factores causales específicos la mayoría de las veces; en las formas crónicas es todavía más difícil reconocerlos. Pueden presentarse síntomas asociados como fiebre, manifestaciones respiratorias, oculares, gastrointestinales o articulares.

Análisis de laboratorio

-Para los pacientes que presentan urticaria de nueva aparición (con o sin angioedema) en los que la historia clínica y el examen físico no sugieren un trastorno subyacente o vasculitis urticarial, las pruebas de laboratorio no están indicadas.

-Para la pacientes en quienes la urticaria será persistente (es decir, presentación inicial de urticaria crónica) se sugiere hemograma con fórmula leucocitaria, análisis de orina, eritrosedimentación y pruebas de función hepática.

-En pacientes en quienes se sospecha una etiología específica, los estudios de laboratorio y la evaluación adicional deben dirigirse a establecer o excluir esa causa.

Pruebas de causas alérgicas

Una causa alérgica es posible si la historia clínica revela un desencadenante específico al que el

paciente estuvo expuesto poco antes del inicio de los síntomas (generalmente dentro de una o dos horas). Las pruebas de suero para anticuerpos de inmunoglobulina E (IgE) específicos de alérgenos son apropiadas. Los pacientes sospechosos de tener una alergia deberían derivarse a un alergólogo / inmunólogo para una evaluación adicional cuando sea posible.

Diagnóstico diferencial

-LOS EXANTEMAS VIRALES: son comunes en los niños y pueden ocurrir con muchas infecciones diferentes, incluyendo eritema infeccioso (quinta enfermedad), virus de Epstein-Barr, enterovirus y sarampión. Sin embargo, los exantemas virales generalmente no son pruriginosos y generalmente consisten en erupciones maculopapulares eritematosas que persisten durante días.

-SÍNDROME AURICULOTEMPORAL: es un enrojecimiento y / o sudoración no pruriginosos de la piel sobre las mejillas o la línea de la mandíbula (las áreas suministradas por el nervio auriculotemporal) que ocurre de manera transitoria después de comer y puede confundirse con urticaria asociada con alergia alimentaria. Se puede ver en niños o adultos y puede desarrollarse después del daño al nervio secundario a la entrega de fórceps, infección viral, cirugía u otro trauma local. La distribución unilateral es típica, aunque se han informado casos bilaterales.

-DERMATITIS ATÓPICA: ver más arriba.

-DERMATITIS DE CONTACTO: se refiere a cualquier dermatitis que surja de la exposición directa de la piel a una sustancia. La dermatitis puede ser alérgica o irritante. Se distribuye en las áreas de contacto directo.

-ERUPCIONES FARMACOLÓGICAS: son reacciones cutáneas farmacológicas que imitan estrechamente los exantemas virales pero que se producen en asociación con un medicamento.

-PICADURAS DE INSECTOS: producen lesiones individuales que persisten durante días en la mayoría de los casos

-ERITEMA MULTIFORME: caracterizado por máculas eritematosas con forma de escarapela y lesiones vesiculosas con apariencia diana. Las lesiones pueden ser dolorosas o pruriginosas y distribuirse simétricamente en las superficies extensoras de las extremidades (particularmente las palmas y las plantas de los pies). Las lesiones individuales duran varios días, a diferencia de la urticaria. Puede haber fiebre y malestar acompañantes.

Tratamiento

El tratamiento inicial debe centrarse en el alivio a corto plazo del prurito y el angioedema, si está presente. Aproximadamente dos tercios de los casos serán autolimitados y se resolverán espontáneamente.

-ANTIHISTAMÍNICOS H1: los antihistamínicos H1 se dividen primera generación (p. Ej. Difenhidramina, clorfeniramina, hidroxizina) y de segunda generación (p. Ej. Cetirizina, loratadina, fexofenadina, otros).

Agentes de segunda generación

Se recomiendan como terapia de primera línea debido a que son mínimamente sedantes, están esencialmente libres de los efectos anticolinérgicos que pueden complicar el uso de agentes de primera generación, tienen pocas interacciones medicamentosas significativas y requieren una dosificación menos frecuente en comparación con los agentes de primera generación.

Los antihistamínicos H1 de segunda generación incluyen lo siguiente:

Cetirizina: demuestra un rápido inicio de acción y cierta actividad estabilizadora de los mastocitos. Puede ser ligeramente sedante, de forma dependiente de la dosis, aunque menos que los agentes de primera generación.

Levocetirizina: es un enantiómero activo de cetirizina que produce efectos equivalentes a la cetirizina en aproximadamente la mitad de la dosis.

Loratadina: es de acción prolongada.

Desloratadina: es el principal metabolito activo de la loratadina y produce efectos equivalentes a la loratadina a aproximadamente la mitad de la dosis.

Fexofenadina: es mínimamente sedante.

Agentes de primera generación

Estos agentes son lipofílicos y cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica, causando efectos secundarios sedantes y anticolinérgicos que pueden limitar la dosis en algunos pacientes. Sedación significativa y deterioro del rendimiento (p. Ej., Habilidades motoras finas, habilidades de conducción y tiempos de reacción) ocurren en más del 20 por ciento de los pacientes. Los efectos secundarios anticolinérgicos incluyen boca seca, diplopía, visión borrosa, retención urinaria o sequedad vaginal. El efecto sedante a la hora de acostarse puede ser beneficioso, especialmente cuando se combina con un antihistamínico H1 no sedante durante el día.

Algunos antihistamínicos H1 de primera generación están disponibles en preparaciones parenterales para su uso en pacientes en los que se desea un inicio de acción más rápido, como aquellos que se han presentado en el departamento de emergencias. La dosificación parenteral de los agentes de primera generación es:

-ANTIHISTAMÍNICOS H2: incluyen ranitidina, nizatidina, famotidina y cimetidina., aunque se debe tener precaución con la cimetidina, ya que puede aumentar los niveles de otras drogas.

-GLUCOCORTICOIDES: se puede agregar un curso breve (una semana o menos) de glucocorticoides sistémicos a la terapia antihistamínica para pacientes con angioedema prominente o si los síntomas persisten más allá de unos pocos días. Los glucocorticoides no inhiben la desgranulación de los mastocitos, pero pueden actuar suprimiendo una variedad de mecanismos inflamatorios contribuyentes.

El esquema indicado sería tratar a todos los pacientes con antihistamínicos H1, agregando antihistamínicos H2 para síntomas más severos y reservando glucocorticoides orales para aquellos pacientes con angioedema prominente o síntomas persistentes a pesar de los antihistamínicos.

Dosis: prednisolona 0.5 a 1 mg /kg/día (máximo 60 mg diarios), con disminución gradual de la dosis durante cinco a siete días.

Para los pacientes cuyos síntomas reaparecen cuando se suspenden los medicamentos, los antihistamínicos deben reinstituirse y usarse a la dosis efectiva más baja. Deben evitarse los ciclos repetidos de glucocorticoides, ya que los riesgos de efectos adversos superan el beneficio para la mayoría de los pacientes.

Escabiosis

La Escabiosis o sarna es causada por un ácaro llamado *Sarcoptes scabiei* variedad *hominis*. Se trata de una ectoparasitosis relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de piel con piel. El prurito es el síntoma más frecuente y empeora característicamente a la noche debido a la mayor la temperatura corporal, comienza alrededor de 3 a 4 semanas después del inicio de la infestación.

Trasmisión

La trasmisión transmisión generalmente ocu-

re a través del contacto directo y prolongado de piel a piel, como puede ocurrir entre miembros de la familia o parejas sexuales. El contacto casual con la piel es poco probable que produzca transmisión.

La transmisión a través de fómites (ropa, ropa de cama u otros objetos) utilizados por una persona con sarna clásica es poco común. La verdadera infestación de sarna no se transmite de animales a humanos.

Los ácaros de la sarna responsables de la sarna animal (es decir, sarna sarcóptica) pertenecen a distintas subespecies y, por lo general, no pueden reproducirse en humanos. Las reacciones a tales ácaros suelen ser autolimitadas y se resuelven si cesa el contacto con el animal afectado.

Epidemiología

La sarna es una infestación relativamente común que puede afectar a personas de cualquier edad y estado socioeconómico. La prevalencia mundial se estima en 100 millones de personas, con una amplia variación en la prevalencia entre regiones geográficas individuales. Con prevalencias más altas en la región del Pacífico y América Latina.

La sarna es particularmente común en regiones con recursos limitados. Las condiciones de hacinamiento aumentan el riesgo de infestación de sarna.

Clínica

El síntoma fundamental es el prurito de predominio nocturno. Inicialmente es localizado y en pocos días se generaliza. Probablemente se debe a una sensibilización a antígenos del ácaro. En lactantes menores de 2 ó 3 meses, el prurito puede estar ausente.

Las lesiones patognomónicas son el surco y la pápula acarina. El primero consiste en una elevación lineal de la piel de pocos milímetros de longitud que corresponde al túnel subcórneo excavado por la hembra del ácaro, capaz de desplazarse unos 5 mm cada día. Al final del mismo existe una pápula o vesícula de 2-3 mm de diámetro, donde está el parásito.

En niños pequeños es frecuente observar pápulas, pústulas y vesículas. A veces también existen pequeños nódulos eritematosos, infiltrados al tacto, preferentemente en el pene y en el escroto, e incluso ampollas.

Las lesiones están enmascaradas por excoriaciones en muchos casos.

Las zonas afectadas son los espacios interdigitales de las manos, la superficie de flexión de las muñecas, los glúteos, la zona genital y la areola mamaria. En los niños pequeños las lesiones predominan en el cuero cabelludo, en el cuello, en la cara, en los pliegues, en las palmas y en las plantas.

La presencia de lesiones exudativas y costrosas es debida a la impetiginización por *Staphylococcus aureus* y, con menor frecuencia, por *Streptococcus pyogenes*.

En pacientes inmunodeprimidos es posible observar infestaciones masivas que provocan lesiones hiperqueratósicas en manos y pies (sarna noruega o costrosa), acompañadas de adenopatías, eosinofilia y escaso prurito.

Complicaciones

Las infecciones secundarias por estafilococos o estreptococos, incluidos impétigo, ectima, paroniquia y forunculosis, con frecuencia complican la sarna clásica.

Diagnóstico

El diagnóstico se confirma mediante la detección del ácaro, los huevos o los gránulos fecales de la sarna mediante un examen microscópico. Sin embargo, dado que estos hallazgos no siempre se detectan fácilmente dado el bajo número de ácaros en pacientes con sarna clásica, la mayoría de las veces se realiza un diagnóstico presuntivo basado en la historia clínica y el examen físico.

Las biopsias de piel generalmente no son necesarias y están reservadas para casos difíciles en los que otros trastornos deben excluirse.

El diagnóstico de sarna clásica debe sospecharse en pacientes con uno o más de los siguientes:

- Picazón generalizada que empeora por la noche, preserva la cabeza (excepto en bebés y niños pequeños) y parece estar fuera de proporción con los cambios visibles en la piel

- Una erupción pruriginosa con lesiones y distribución características.

- Otros miembros del hogar con síntomas similares.

Cuando se presentan placas gruesas, con costrosas y fisuradas, o lesiones características en pacientes inmunodeprimidos sospechar sarna costrosa.

Los surcos a menudo no son evidentes en el examen físico, pero, cuando se ven, apoyan firmemente el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial

Se plantea principalmente con otras erupcio-

nes pruriginosas, tales como el eccema atópico, la sudamina y las toxicodermias.

Las lesiones vesículo-pustulosas en niños pequeños pueden confundirse con foliculitis esta-filocócicas, acropustulosis infantil, histiocitosis de células de Langerhans o varicela.

Las lesiones pápulo-nodulares eritemato-par-duzcas pueden sugerir una mastocitosis (urtica-ria pigmentosa).

La sarna noruega puede simular una psoriasis.

Tratamiento

El tratamiento se basa en la aplicación de per-metrina 5% en todo el cuerpo desde el cuello hasta los pies en todos los convivientes, tengan o no tengan lesiones, dejando actuar 6 a 8 horas.

Para los casos de bebés menores de 1 año se indica tratamiento con permectrina 5% o vaseli-na azufrada por 4 horas.

La permectrina es la droga de primera elección en recién nacidos, lactantes y embarazadas.

Luego, se retira la loción y los pacientes deben vestirse con ropa lavado con agua caliente, se-cada al sol y planchada.

La ropa que no se pueda lavar, se guarda en bolsas cerradas durante 3 días.

Se debe repetir la aplicación de los acaricidas a la quinta y décima noches.

La ivermectina, puede ser utilizada en mayores de 15 kg de peso a una dosis de 200 ug/kg vía oral y repetirse a los 15 días.

Su uso estaría indicado para el tratamiento de la sarna costrosa y para aquellos casos donde el tratamiento local empeoraría una enferme-dad subyacente, como psoriasis generalizada, eccema atópico severo o epidermolisis ampo-llar. También podría considerarse su uso en pa-cientes con prótesis, yesos que cubran grandes porcentajes del cuerpo y en aquellas situaciones donde el baño posterior es dificultoso.

Se pueden utilizar antihistamínicos para tratar el prurito ya que el mismo puede incluso persis-tir hasta un mes después del tratamiento.

En los nódulos escabióticos, se utilizan cremas con corticoides de baja o mediana potencia. Si existe sobreinfección bacteriana se pueden rea-lizar fomentos con antisépticos y antibióticos tópicos (ácido fusídico o mupirocina) o antibió-ticos orales (cefalexina, eritromicina) de ser le-siones muy extensas.

Bibliografía

- Beth G. Goldstein, MD; Adam O. Goldstein, MD *Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis*. Post TW.
Comité de Dermatología Pediátrica. Escabiosis. Sociedad Argentina de Pediatría. <http://sap.org.ar/>
Denis Spelman, MBBS, FRACP, FRCPA, MPH; Larry M. Baddour, MD, FIDSA, FAHA. *Cellulitis and skin abscess in adults: Treatment*. Post TW, ed.
Eseverri Asín JL. *Urticaria* Asociación Española de Pediatría www.aeped.es
Fonseca Capdevila E. *Dermatitis atópica*.
García V, Patos Briones. *Escabiosis*. (Pag. 159-163). Asociación Española de Pediatría. <https://www.aeped.es>
Giachetti, A y col. *Consenso Nacional de Dermatitis Atópica 2013. Resumen ejecutivo Arch Argent Pediatr 2014;112(3):293-294* <http://sap.org.ar/>
Larry M. Baddour, MD, FIDSA, FAHA. *Impetigo*. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA:
Manzur G, C Maza, JA Máximo *Dermatitis Atópica*.
Moyano M y col.. *Infecciones de piel y partes blandas en pediatría: Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento Sociedad Argentina de Pediatría Subcomisiones, Comités y Grupos de Trabajo*. Arch Argent Pediatr 2014;112(1):e96-e106
Nebreda Pérez V. *Urticaria*. Capítulo 26. *Angioedema Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP* (Pag 255-261).
William L Weston, MD William Howe, MD *Atopic dermatitis (eczema): Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis* Post TW, ed.
William L. Weston, MD; William Howe, MD *Tratamiento de dermatitis atópica (eccema)* Post TW, ed.

***Dra. Cintia Esquivel**

Médica Pediatra, Carrerista de dermatología pediátrica en HNRG (2º año). Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

****Dra. Daniela Pereyra Bettoni**

Médica Pediatra. Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

*****Dra. Claudia Chiavazza**

Jefa de pediatría. Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

******Dra. Ianina Massimo**

Dermatóloga pediátrica Hospital de Niños Ricardo Gutierrez de CABA.

VICIOS DE REFRACCIÓN EN PEDIATRÍA



DRA. SABRINA CARME*

DRA. FLORENCIA PRUSCINO**

DRA. MELISA RUBIO***

DRA. DANIELA GUTIÉRREZ****

DRA. SABRINA CICERO*****

DRA. KARINA DUEÑAS*****

DRA. ANDREA SANCILIO*****

DRA. CLARISA MENESCALDI

Revisora

Sumario

Los vicios de refracción presentan una prevalencia del 9% en niños de edad escolar. La detección precoz de los vicios de refracción, habitualmente asintomáticos, es un reto para el pediatra, porque permitiría mejorar la capacidad y el desarrollo visual, así como el rendimiento escolar y el desempeño social de los niños.

Caso clínico

Facundo, de 7 años de edad, es traído por su mamá a la segunda consulta con su pediatra de cabecera por los episodios repetidos de cefalea que viene presentando en los últimos 3 meses.

Antecedentes: paciente RNT/PAEG, recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, vacunas completas para edad. Sin antecedentes patológicos personales ni familiares de relevancia. Convive con ambos padres y sus dos hermanos de 10 y 3 años respectivamente.

Su pediatra realiza un examen físico completo encontrándolo en BEG, eucárdico, eupneico, afebril; TA en Pc 50. Pautas madurativas acordes a su edad. Su mamá refiere que el rendimiento escolar disminuyó en el último tiempo siendo coincidentes con el comienzo de los episodios

de cefalea, que no presenta en el momento de la consulta.

Del calendario de cefaleas que realizó por indicación médica se resumen los siguientes datos positivos: se presentan principalmente por la tarde al regresar de la escuela, mejora tras el descanso nocturno, no ocurre los fines de semana, cede con analgésicos y no presenta “banderas rojas”.

Sugiere pautas higiénico-dietéticas y continuar valoración por oftalmología.

Al concurrir al oftalmólogo se constata una visión de 4/10 en ambos ojos. Se realiza además el examen de movimientos oculares, estereopsis, lámpara hendidura y fondo de ojos (con dilatación pupilar) sin particularidades. Bajo ciclopegeia (dilatación pupilar con ciclopentolato 1%, que produce parálisis de la acomodación además de midriasis), se observa miopía de -1,00 y astigmatismo de -2,00 a 90 en ambos ojos.

Se decide la prescripción de lentes aéreos y se cita a nuevo control en 1 mes para evaluar la persistencia o no de síntomas.

Introducción

Los vicios de refracción (miopía, hipermetropía

y astigmatismo) son una patología frecuente en la edad pediátrica, muchas veces sub diagnosticados por la falta de consulta oftalmológica oportuna. Clásicamente presentan una prevalencia del 9% en niños de edad escolar, siendo el astigmatismo hipermetropico el más frecuentemente detectado.

En los últimos años se ha observado a nivel mundial un aumento alarmante de jóvenes adultos con miopía, sobre todo en países asiáticos: el 90% la padece, esto también se ha comenzado a ver en el resto del mundo; según la OMS, para el 2050 1 de cada 2 personas en el mundo la padecerán.

La detección precoz de los vicios de refracción, habitualmente asintomáticos, es un reto para el pediatra, porque permitiría mejorar la capacidad y el desarrollo visual, así como el rendimiento escolar y el desempeño social de los niños.

Exploración oftalmológica pediátrica

El examen oftalmológico completo, con lámpara hendidura y fondo de ojos bajo dilatación pupilar, lo realiza el oftalmólogo, pero existen varios exámenes sencillos de screening que los puede realizar el pediatra en su consultorio.

Cuando se realiza el examen oftalmológico en niños debemos centrarnos en dos aspectos: la agudeza visual, y la existencia de estrabismo.

Para evaluar la agudeza visual se dispone de varios métodos, según la edad y el nivel cognitivo del niño. En los niños pre verbales se puede evaluar la actitud visual:

Recién nacidos: predilección por mirar el rostro humano respuesta a la luz intensa.

Lactantes: si fija, sigue y mantiene la mirada en un objeto cercano, de colores.

En los niños más grandes o colaboradores se realizará el test elegido (fig. 1), de lejos y cerca. Siempre es deseable poder hacerlo con cada ojo por separado.

Para evaluar la existencia o no de estrabismo, existen test sencillos que el pediatra puede realizar:

Reflejo rojo: se debe realizar en habitación os-

cura, logrando la mayor midriasis posible. Se iluminará a través de oftalmoscopio directo ambos ojos en simultáneo, evaluando la simetría del reflejo. Cuando el mismo esta alterado se ve blanco y se denomina leucocoria. Esto implica patología ocular grave y debe ser derivado al oftalmólogo rápidamente. Las situaciones que alteran este test son principalmente los grandes estrabismos, las opacidades como las cataratas congénitas y retinoblastoma, y las ametropías severas.

Reflejo corneal: Consiste en iluminar con un oftalmoscopio directo al niño y llamar su atención. Observaremos si el reflejo que se produce en las córneas de nuestro paciente está correctamente centrado en ambas pupilas (respuesta normal) o si hay un ojo centrado y otro descentrado (ojo estrábico).

Vicios de refracción

El periodo de maduración visual comienza al nacimiento y finaliza, aproximadamente, a los 7-8 años.

A diferencia del ojo normal, cuando existe un vicio de refracción, la imagen del objeto no se proyecta sobre la retina, dando lugar a una visión poco nítida y menor agudeza visual. Para mejorar la nitidez de la imagen es necesario un esfuerzo acomodativo.

Aunque la corrección con lentes permite compensar la mayoría de los defectos de refracción, normalizando la agudeza visual, la presencia de ametropías (vicios de refracción) no detectadas a tiempo durante la primera infancia puede interferir con el proceso madurativo visual, cuya expresión más grave es la ambliopía (ojo perezoso).

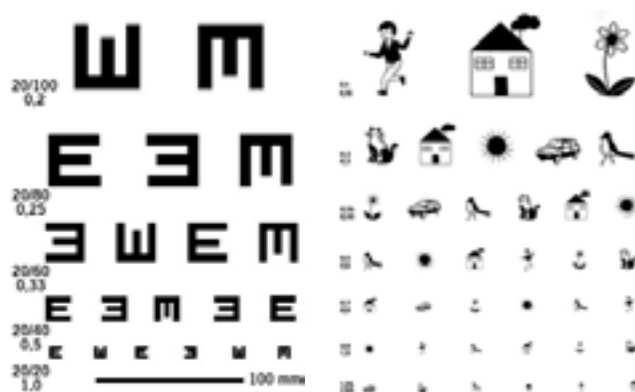


Fig. 1. Optotipos

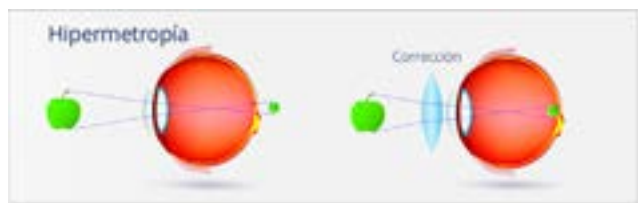
Los factores determinantes de los errores refractivos son hereditarios y ambientales. Los valores de estas ametropías a los 5 años de edad son predictivos, es decir si el niño es miope a esa edad, quedara miope y esto progresara y, si es hipermetrope mayor a +1,5 D quedará hipermetrope.

Hipermetropía

La hipermetropía, defecto en donde el ojo tiene una longitud axial más corta de lo esperado para la edad, es la más frecuente en la edad pediátrica. Esto provoca que la imagen que debería ser proyectada en la retina lo haga detrás de la misma (Img. 2)

En el niño el proceso de acomodación es muy activo, lo cual determina que con esfuerzo visual sostenido la imagen pueda proyectarse en la retina, dando lugar a una agudeza visual normal a pesar del defecto. Esto genera síntomas relacionados: ojos rojos después de leer o escribir, cefalea, falta de interés en actividades que requieren visión próxima, interferencia en el aprendizaje, estrabismo convergente compensatorio.

El mayor problema ocurre cuando la hipermetropía es asimétrica, lo que produce una imagen borrosa en el ojo con mayor graduación, generando en el niño ambliopía.



Img. 2: ojo con hipermetropía, se observa la proyección de la imagen detrás de la retina. El objetivo de lentes biconvexas o convergentes es lograr que la proyección sea a nivel de la retina.

Miopía

La miopía es una ametropía secundaria a presentar un ojo con eje axial antero posterior más largo de lo normal. Esto provoca que la imagen se proyecte delante de la retina (Img. 3)

En ocasiones, también puede ser debida a un cristalino más pequeño, lo que determina que se forme la imagen por delante de la retina, a

pesar de un eje antero posterior normal (más frecuente en niños prematuros).

Este defecto condiciona compromiso para la visión lejana, no pudiendo acomodarse. La visión de cerca es normal, y el niño se acerca excesivamente a los objetos para verlos bien.

La miopía puede ser congénita o adquirida, siendo esta última la más frecuente.

Las congénitas son habitualmente más severas, y no progresan durante el crecimiento, mientras que las adquiridas si lo hacen durante la infancia y adolescencia. Las miopías elevadas pueden asociarse a enfermedades sistémicas como en el síndrome de Alport, de Alagille, albinismo, Down, Ehlers-danlos, Marfan, Laurence Moon Bield, Stickler y otros.

Las miopías graves, presentes en los primeros años de vida, pueden generar ambliopía. Cuando la miopía es >-5 , se la denomina miopía patológica y puede asociarse a glaucoma, catarata precoz, alteraciones retinales, desprendimiento de retina.



Imagen. 3: ojo con miopía, se observa la proyección de la imagen delante de la retina. El objetivo de lentes biconcavas o esféricas - es lograr que la proyección sea a nivel de la retina.

Astigmatismo

En el astigmatismo existe una anormal curvatura de la córnea principalmente, que se encuentra más aplanado en un eje, lo cual provoca un desenfoque tanto de cerca como de lejos (Img. 4).

En este caso, la refracción es diferente en los



Img. 4: los ojos tienen forma abombada, formando dos puntos de focalización. Los objetos se ven dobles o sombreados.

distintos meridianos, debido a diferencias en los radios de la curvatura corneal, lo cual determina que las imágenes se proyecten dobles en la retina, generando visión borrosa.

Los astigmatismos afectan sensiblemente a la agudeza visual y producen cansancio (asteno-pia), dando lugar a ojos rojos después de leer o escribir, parpadeo, cefalea e interferencia en el aprendizaje.

El astigmatismo suele mantenerse relativamente estable a lo largo de la vida. Combinado o no con otras ametropías, muy especialmente, cuando son asimétricos, es causa de ambliopía.

Ambliopía

La ambliopía se define como disminución de la agudeza visual de uno o, más raro, de ambos ojos, a pesar de corregir adecuadamente el defecto de refracción. La reducción de la agudeza visual es debida un desarrollo inadecuado de las áreas cerebrales de la visión. Sus causas pueden ser refractivas, sensoriales o estrábicas. En las refractivas, o sea causada por los vicios de refracción, como regla general una miopía mayor a -2D, hipermetropía mayor a +4D y un astigmatismo mayor a -1,5D da ambliopía y debe ser corregido.

Cuanto mayor sea la diferencia de refracción entre ambos ojos y menor sea la edad del niño, más probable y grave será la interferencia con la maduración visual y mayor el riesgo de ambliopía. La mayor susceptibilidad es cuando la anisometropía se produce en los primeros 2 o 3 años de vida.

La ambliopía es la causa prevenible de pérdida de visión más importante en la edad pediátrica.

Tratamiento

No todos los vicios de refracción necesitan ser corregidos.

El tratamiento lo debe realizar el oftalmólogo teniendo en cuenta la edad del paciente, los síntomas, la motilidad ocular y las necesidades visuales (exigencia escolar).

Existen distintos tratamientos médicos y quirúrgicos.

Anteojos: Debe considerarse a cada paciente como caso individual, pueden prescribirse lentes aéreos. En las ambliopías refractivas el primer paso es el empleo de la corrección óptica adecuada, de no mejorar se propone el tratamiento con oclusión o penalización.

Lentes de contacto. Se pueden recetar a cualquier edad, dependiendo de las necesidades del niño y su adherencia al uso.

Cirugía refractiva: los distintos tipos de cirugía refractiva (LASIK, LASEK, PRK, lente intraocular) solo está indicada en algunos casos de niños mayores, cuando no toleran la corrección o algunos estrabismos. Es controversial. En general se espera a la mayoría de edad y la estabilización del ER antes de operarse.

Debido a la gran epidemia de miopía en los últimos años, se desarrollaron distintos tratamientos que tienen como objetivo evitar la progresión de la misma, como la ortoqueratología, los lentes de contacto bifocales y la atropina. De estos se acepta que la colocación de atropina tópica al 0,01% es el más efectivo. Actualmente, se utiliza atropina al por la noche, en niños > 7 años, cuando presentan una franca progresión en dioptrías de la miopía. Dada la dilución de la droga tiene leves efectos adversos (fotofobia, visión borrosa de cerca) y es bien tolerada en la población pediátrica.

A la fecha, en nuestro país no lo comercializa ningún laboratorio.

Prevención

Es importante que los niños realicen los controles oftalmológicos en momento recomendado, para que el especialista detecte los errores refractivos y otras patologías en el momento oportuno y sea tratado adecuadamente.

La Sociedad de Oftalmología Infantil y la Academia Americana de Pediatría sugieren controles periódicos:



En cuanto a la miopía, se sugiere disminuir el tiempo de trabajo de cerca y aumentar el tiem-

po al aire libre. Este último sería un factor protector no solo de la progresión de la misma sino también retrasaría su aparición.

Comentarios del especialista

Los vicios de refracción son una patología frecuente y conocida en los niños, por lo que es de buena práctica médica para el pediatra reconocerlos, para realizar una consulta oportuna con el oftalmólogo especialista.

Para esto, el pediatra debe recordar los tests de pesquisa sencillos que puede realizar en forma rápida y fácil en su consultorio, después de un buen interrogatorio a los padres: la toma de agudeza visual según la edad, el reflejo rojo y el reflejo corneal. Estos exámenes brindan información sobre el estado visual del niño, estrabismo y patología de mayor gravedad (leucocoria).

El oftalmólogo realizara una consulta completa, con examen de lámpara hendidura, toma de presión intraocular y fondo de ojos bajo dilatación pupilar para determinar con mayor precisión la patología del paciente y la necesidad o no de corregirla. Además, podrá detectar el riesgo de ambliopía y también tratarlo.

Además el pediatra debe recordar las edades en las que se recomienda realizar un examen oftalmológico a toda la población infantil.

En los últimos años ha crecido a nivel mundial el porcentaje de niños con miopía, cada vez a edades más tempranas, lo cual es de gran preocupación. Si bien no hay datos actuales de nuestro país, se estima que en los países asiáticos la prevalecía de jóvenes adultos con miopía es del 90%, y esto se está extendiendo hacia el occidente. Niños que comienzan con miopía a edad temprana tienen posibilidad de mayor progresión de la misma, llegando a miopías más altas, que traen complicaciones; catarata precoz, glaucoma, desprendimiento de retina, por lo que se trata de un tema no menor, de calidad de vida y de salud pública.

Está estudiado a nivel mundial que el tiempo al aire libre y menor trabajo de cerca de los ojos son un factor ambiental que previene o retrasa la aparición de este vicio de refracción. Al igual que el menor uso de las pantallas, son factores modificables en los que se debe hacer hincapié con cada familia.

Bibliografía

- Berri GG, E. Manzitti, A.O Ciancia, M.Calvo de Zamora. La visión en el niño: vicios de refracción. Archivos argentinos de pediatría, tomo LXXXI num 1, marzo 1973.
- Deepinder K Dhalival MD. Generalidades de los defectos de refracción. Manual MSD. Febrero 2017.
- Diez del Corral Belda JM. Oftalmología pediátrica para todos los días, AEPap ed curso de actualización pediátrica. Madrid, febrero 2015.
- Manzitti J, V Hawiller. Oftalmología pediátrica, Consejo argentino de oftalmología, Universidad Católica de Salta, 2007.
- Soroide Duran E, Rafael Iribaren. Refracción clínica y quirúrgica, Consejo argentino de oftalmología, Universidad Católica de Salta, 2005.
- Valls Ferran M; A. Clement, C.Jiménez. Detección precoz de los defectos de refracción. Hospital Universitario del Niño Jesús, Madrid. Pediatría Integral vol XVII N° 7, curso V, septiembre 2013.

*Dra. Sabrina Carme

Médica Residente 4° año, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

**Dra. Florencia Pruscino

Médica Residente 4° año, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

***Dra. Melisa Rubio

Médica Jefa de Residentes, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

****Dra. Daniela Gutiérrez

Médica Residente 3 año, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

*****Dra. Sabrina Cicero

Médica Residente 3 año, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

*****Dra. Karina Dueñas

Médica Jefa de Servicio, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

*****Dra. Andrea Sancilio

Médica Instructora de Residentes, Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

*****Dra. Clarisa Menescaldi. Revisora

Oftalmopediatra Hospital Evita Lanús. Servicio de pediatría

LA EPILEPSIA EN LA EDAD ESCOLAR



DR. MAURICIO TOMÁS PEDERSOLI CASTELLANI*

Sumario

La epilepsia es una condición frecuente en la edad escolar. Se estima que 10,5 millones de niños menores de 15 años padecen epilepsia en todo el mundo, lo que representa el 25% de la población epiléptica global.

El papel del pediatra de Atención Primaria para su diagnóstico correcto, así como para el seguimiento posterior del paciente epiléptico, es fundamental.

Introducción

El abordaje diagnóstico y terapéutico de la epilepsia en la edad escolar es complejo y suele requerir un manejo por parte del especialista en neurología, sin embargo, el primer contacto con el paciente y las primeras impresiones diagnósticas las hace el pediatra que lo recibe en consultorio o en la guardia de un hospital.

Para poder construir un diagnóstico correcto de epilepsia, es necesario conocer los conceptos de crisis epiléptica, epilepsia y síndromes epilépticos que la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) actualiza de forma periódica. De esta manera lograremos una mayor diferenciación de los tan frecuentes trastornos que simulan crisis (trastornos paroxísticos no epilépticos).

Crisis epiléptica: es el acontecimiento transitorio de signos y/o síntomas debidos a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro. Presentar una crisis epiléptica no significa necesariamente que una persona tiene epilepsia, dado que la misma puede ser provocada por otras causas. De ahí que podemos clasificarlas en no provocadas y no provocadas en caso de que exista una causa aguda que lo justifique (hipoglucemia, infección, conmoción

cerebral).

En función de la localización cerebral del área epileptogénica, podemos definir 2 tipos de crisis:

- Crisis generalizadas: son aquellas que se inician en algún punto del cerebro con capacidad para que la descarga epileptógena se distribuya de forma rápida y bilateral por todas las estructuras corticales y/o subcorticales.

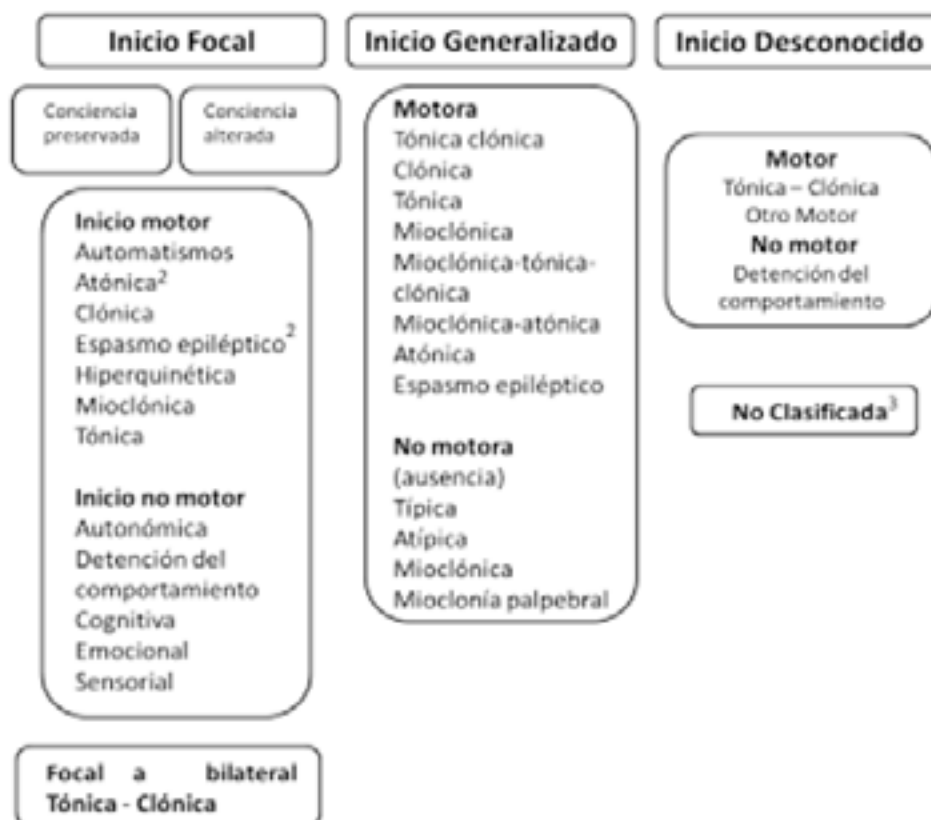
- Crisis focales: la descarga se origina en redes neuronales limitadas a un hemisferio. La localización puede ser más o menos amplia. Cada tipo de crisis tiene un comienzo constante, con patrones de propagación preferenciales que pueden involucrar al hemisferio ipsi o contralateral.

La ILAE en 2017 presenta la nueva clasificación operacional de crisis epilépticas generando las siguientes modificaciones respecto a la clasificación previa:

Para las crisis focales, especificar el nivel de alteración de conciencia es opcional. Conservar el nivel de conciencia quiere decir que la persona tiene conciencia de sí misma y de su entorno durante la crisis. Una crisis focal sin alteración del nivel de conciencia corresponde al término previo de crisis parcial simple. Una crisis focal con alteración del nivel de conciencia corresponde al término previo de crisis parcial compleja, y se refiere a la alteración del nivel de conciencia durante cualquier parte de la crisis.

Las crisis focales sin y con alteración del nivel de conciencia, opcionalmente pueden caracterizarse por uno de los síntomas de inicio motor o no motor, reflejando el primer signo o síntoma prominente en la crisis. Las crisis deben ser clasificadas por la manifestación más temprana y prominente, excepto cuando la crisis sea por detención del comportamiento en la cual el cese de actividad es la manifestación dominante du-

Clasificación Operacional de los Tipos de Crisis, Versión Extendida ILAE 2017¹



rante la crisis. Una crisis puede estar en la categoría de no clasificada debido a inadecuada información o imposibilidad de ubicarla en las otras categorías de tipos de crisis.

El término “focal a bilateral tónico-clónica” reemplaza el de focal “secundariamente generalizada”.

Epilepsia: la actual definición de epilepsia ya no está restringida a la aparición persistente de crisis epilépticas, sino que se presenta como una enfermedad cerebral que implica la existencia de cualquiera de las siguientes condiciones:

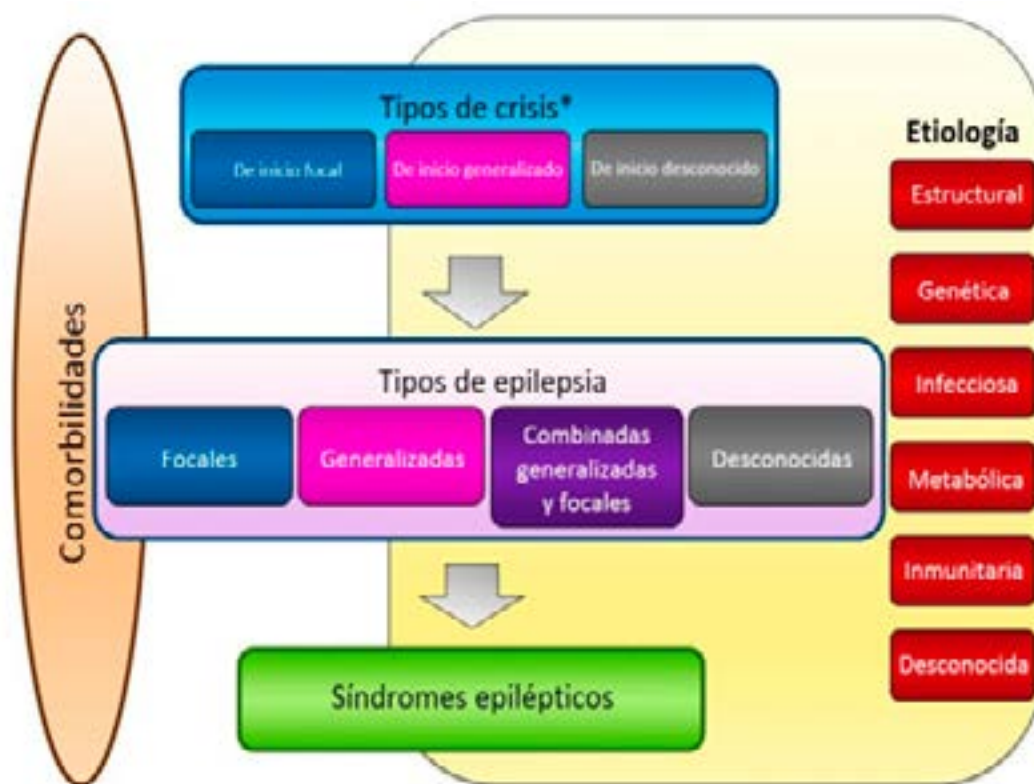
1. Al menos, dos crisis epilépticas no provocadas (o reflejas), que ocurran separadas por un plazo superior a 24 horas.
2. Una sola crisis epiléptica no provocada (o refleja) unido a una alta probabilidad por el origen causal de la misma, de que aparezcan más crisis durante los 10 años siguientes (similar al riesgo de recurrencia que hay después de presentar dos crisis no provocadas (al menos de un 60%)). Por ejemplo, si aparece una crisis no provocada en un paciente con antecedente de ACV (no agudo), la literatura sugiere un alto riesgo de aparición de otra crisis no provocada, por lo que se puede hablar de epilepsia con una sola crisis.
3. Cuando se diagnostica un síndrome epiléptico

específico (conjunto de características que incorporan tipos de crisis, EEG, características de diagnóstico por imágenes, y comorbilidades, que suelen presentarse juntas).

Intentar diagnosticar en los 3 niveles (tipo de crisis, epilepsia y síndrome) junto a etiología (puede tener más de una) y comorbilidades.

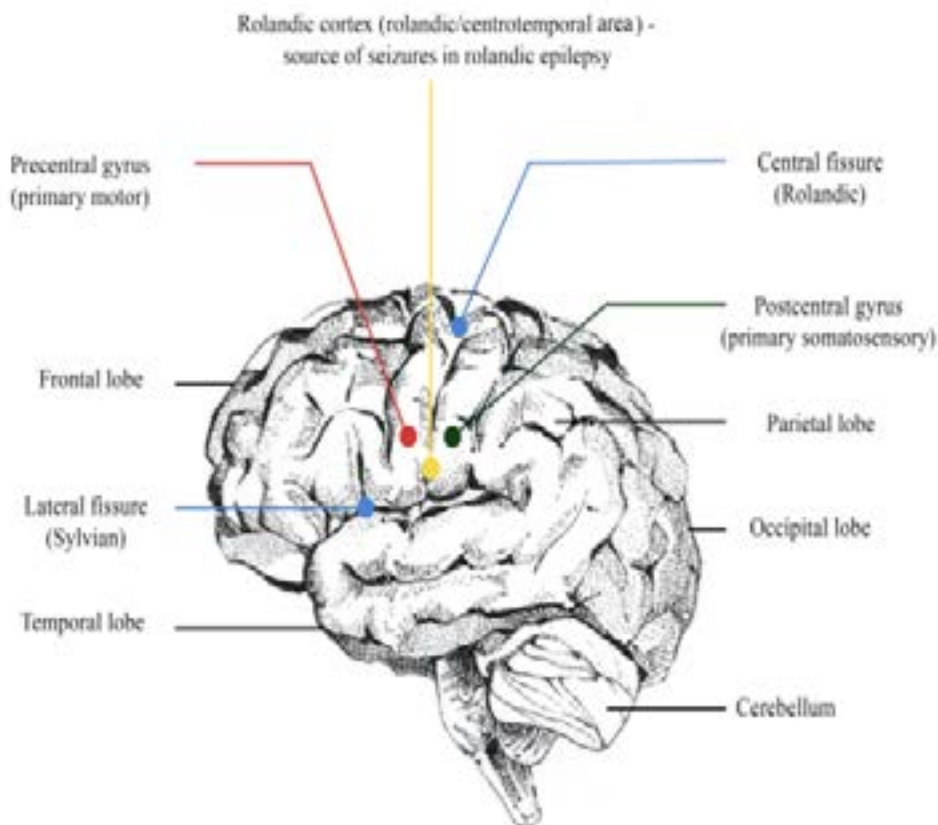
Dentro de los síndromes epilépticos de la niñez y adolescencia encontramos las epilepsias focales autolimitadas (anteriormente llamadas “benignas de la infancia”: Epilepsia “Rolándica”, Sme de Panayiotopoulos y Sme de Gastaut) y las epilepsias generalizadas genéticas (ex idiopáticas).

En la edad escolar la epilepsia más frecuente corresponde a la epilepsia Rolándica, actualmente denominada epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales. Por este motivo considero de suma importancia el reconocimiento precoz del síndrome para una eventual derivación oportuna.



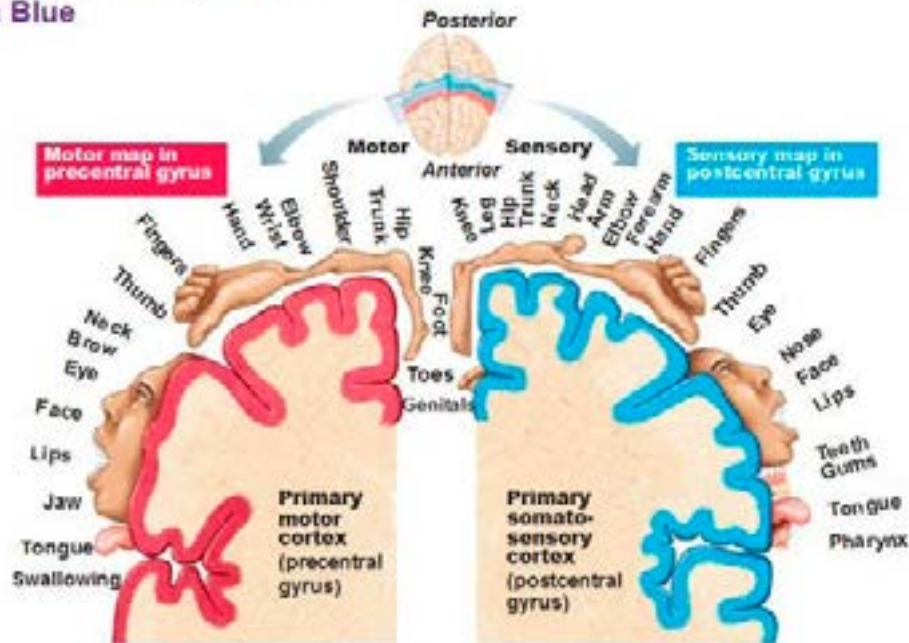
"Hasta un 80% de las epilepsias llegan a ser clasificadas en síndromes epilépticos. El 60% se diagnostican con las primeras manifestaciones críticas y un EEG, y el 20% restante, tras un seguimiento evolutivo de hasta 2 año".

Epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales:



Homunculus of Primary Somatosensory Cortex in Blue

Note that each hemisphere receives info from the opposite side of the body



Epilepsia focal autolimitada occipital de inicio temprano (Síndrome de Panayiotopoulos): síndrome más frecuente en el preescolar, de inicio en torno a los 5 años (3-6 años), que consiste en crisis focales prolongadas (más de 30 minutos)

que se caracterizan por una clínica autonómica, con fenómenos de palidez, náuseas, vómitos, midriasis, síncope y que pueden generalizarse a continuación. Suelen despertarse por la noche con desviación oculocefálica, vómito ictal y

clonías del mismo hemisferio. Es frecuente la aparición de anomalías occipitales en el EEG o en otras localizaciones. Su curso es benigno hacia la resolución espontánea, por lo que no suele recomendarse tratamiento salvo en los casos con crisis frecuentes (carbamacepina, valproico, oxcarbamacepina, levetiracetam, o clobazam nocturno). Se describen evoluciones atípicas con peor pronóstico.

Epilepsia focal autolimitada occipital de inicio tardío (Síndrome Gastaut): inicio en torno a los 8 años con crisis frecuentes que se caracterizan por una clínica visual con alucinaciones, amaurosis, desviación ocular, puede haber generalización secundaria y, en algunos casos, queda una cefalea residual migrañosa. El principal diagnóstico de este síndrome es la migraña con aura visual, sirviéndonos el EEG para poder diferenciar ambas entidades. El EEG interictal se encuentra alterado con complejos punta onda en regiones occipitales o temporales posteriores, activados con el cierre ocular. Se recomienda tratamiento con carbamacepina o clobazam.

Dentro de las epilepsias generalizadas genéticas se destacan por frecuencia en la niñez la Epilepsia Ausencia de la niñez y en el adolescente la Epilepsia mioclónica juvenil:

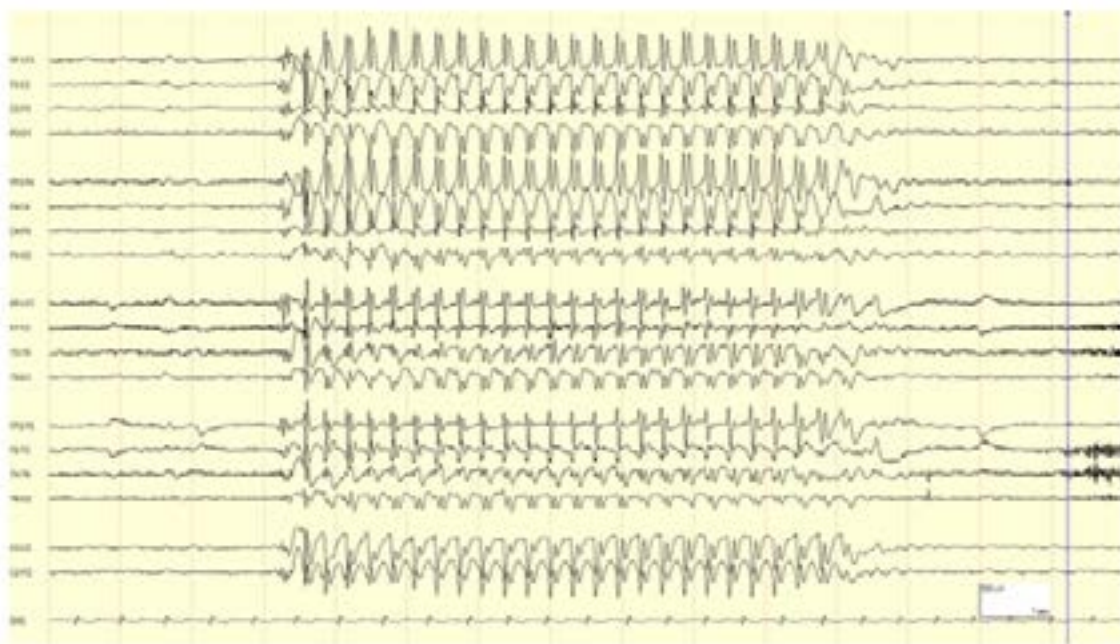
Epilepsia ausencias de la niñez: es una entidad muy frecuente (hasta el 8% de los niños en edad escolar), con un pico de incidencia máximo en torno a los 6 años. Son niños sanos en los que

aparecen crisis generalizadas consistentes en detención de la actividad, sin pérdida del tono, con mirada fija o en supravversión durante escasos segundos de duración y con recuperación posterior completa. Pueden asociar: parpadeo, chupeteo o automatismos manuales. Si duran más de 45 segundos o tienen postictal considerar crisis focal. Si debuta antes de los 4 años pensar en déficit de transportador de glucosa. Es muy característico el inicio de la crisis tras la hiperventilación (soplar durante 3 minutos).

Presentan un patrón electroencefalográfico típico con punta onda generalizada a 3 Hz de predominio en áreas anteriores, con hiperventilación positiva. RMN de encéfalo normal. Se han detectado alteraciones genéticas asociadas (genes CACNA1G y CACNA1H) y la presencia de historia familiar de epilepsias generalizadas es habitual. Responden satisfactoriamente al tratamiento con valproico o etosuximida y lamotrigina. Hasta el 90% de los casos está libre de crisis en la vida adulta.

Epilepsia mioclónica juvenil: Es muy frecuente. Se inicia entre los 12-18 años, un tercio tiene antecedentes de historia familiar de epilepsia.

Se caracteriza por crisis a los pocos minutos de despertar, de tipo mioclónico (sacudidas musculares bruscas) y de predominio en brazos y manos, sin alteración de conciencia. La gran mayoría de los pacientes presentan crisis tó-



Paroxismos generalizados a 3 ciclos por segundo (3 punta onda en un segundo), típico de la epilepsia ausencia de la niñez.

nico-clónicas generalizadas en relación con la privación de sueño, alcohol o la menstruación, como primera consulta. “El paciente suele referir que antes de las crisis tónico clónico había presentados episodios matutinos donde se les caían las cosas (taza, peine, lápiz, o el celular) sin entender el motivo (mioclonías). Algunos asocian ausencias por lo que debe interrogarse sobre episodios breves de desconexión.

El EEG interictal muestra actividad de base normal con paroxismos generalizados de punta onda y polipunta onda a 3-5 Hz. La evolución es buena, pero muy dependiente de tratamiento. Las crisis se controlan con valproico o levetiracetam (de preferencia en mujeres en edad fértil), pero recurren frecuentemente al suspenderse el tratamiento. Recordarle que dormir bien es tan importante como tomar la medicación todos los días.

Función del pediatra de atención primaria

Para confirmar el diagnóstico y pautar el tratamiento se recomienda la derivación y la colaboración del neuropediatra, ya que va a ser necesaria la realización de exámenes complementarios y el manejo terapéutico que puede ser complejo en algunos casos. En el seguimiento posterior clínico y terapéutico del paciente, la labor del pediatra de Atención Primaria va a ser imprescindible para detectar precozmente efectos secundarios, empeoramiento en número y frecuencia de crisis y valorar, en conjunto, la calidad de vida del paciente y su familia.

Más allá de las eventuales complicaciones siempre enfatizar que el 75 % de las epilepsias tienen buen pronóstico, logrando el control de las mismas o autolimitándose en función de la edad.

Bibliografía

- Alva Moncayo E. Síndromes epilépticos en la infancia. *Rev Med Inst Mex.* 2011; 49: 37-44.
- Arzimanoglou A, French J, Blume WT, Cross JH, Ernst JP, Feucht M, Genton P, Guerrini R, Kluger G, Pellock JM, Perucca E, Wheless JW. *Lennox-Gastaut syndrome: a consensus approach on diagnosis, assessment, management, and trial methodology.* *Lancet Neurol.* 2009; 8: 82-93.
- Casali R, Ramos do Amaral M, Boscaroli M, Lorencetti Lunardi L, Mantovani Guerreiro M, Gentile Matas C, et al. *Comparison of auditory event-related potentials between children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes and children with temporal lobe epilepsy.* *Epilepsy Behav* 2016; 59:111
- Cavazzuti G, Cappella L, Nalin A. *Longitudinal study of epileptiform*

Epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales

Síndrome más frecuente en edad escolar. Inicio: 3 a 12 años (media: 8 a 9 años). Más frecuente en varones (3:2). 5-15% antecedente de convulsiones febriles. 18-36 % familiares epilépticos. Examen físico y desarrollo previo normal. En su mayoría autolimitado en la adolescencia. 1-4 % evoluciones atípicas más severas, con compromiso neuropsicológico, de la conducta o el lenguaje (epilepsia con punta onda continua en sueño lento, Sme de Landau kleffner o EBNECT atípica).

Zona epileptogénica: alteración de redes neuronales de la corteza somatosensorial baja (región de la cisura de Silvio y de Rolando), especialmente en la parte baja del giro pre y post central que representa la cara y orofaringe bilateralmente (homúnculo motor y sensorial), causales de la sintomatología autonómica sensoriomotriz.

EEG interictal: espigas centrotemporales, anchas, bifásicas, de alto voltaje, uni o bilaterales. RMN encéfalo con protocolo de epilepsia: normal. Tratamiento: Si son frecuentes o diurnas: ácido valproico, carba u oxcarbacepina. Otros: levetiracetam, lacosamida, lamotrigina. Si son sólo nocturnas: clobazam 10mg a la noche. Si son aisladas: puedo esperar y ver la evolución, excepto ansiedad familiar. Evolución atípica: rotar esquema a etosuccimida, clobazam o sultiam.

Clínica: Crisis focales nocturnas durante el sueño o al despertarse a la mañana, breves, con movimientos orolingüofaciales (ej: clonías de comisura labial inferior), sialorrea, disartria, y síntomas somatosensitivos (parestias o adormecimiento de lengua, labios, encía, mejilla y dientes). Trastornos neurocognitivos transitorios.

EEG patterns in normal children. *Epilepsia* 1980;21:43-55.

Chadwick D. Starting and stopping treatment for seizures and epilepsy. *Epilepsia*. 2006; 47(Suppl. 1): 58-61

Dryżałowski P, S. Jóźwiak, M. Franckiewicz, J. Strzelecka. Benign epilepsy with centrotemporal spikes Current concepts of diagnosis and treatment.

García-Ramos C, Jackson D, Lin J, Dabbs K, Jones J, Hsu D, et al. Cognition and brain development in children with benign epilepsy with centrotemporal spikes (BECTS). *Epilepsia* 2015; 56(10):1615-22.

López IM, Varela X, Marca S. Síndromes epilépticos en niños y adolescentes. *Rev. Med. Clin. Condes*. 2013; 24: 915-27.

Mellish LC, Dunkley C, Ferrie CD, Pal D. Antiepileptic drug treatment of rolandic epilepsy and Panayiotopoulos syndrome: clinical practice survey and clinical feasibility. *Arch Dis Child* 2014; 100:62-7.

National Institute for Clinical Excellence. The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. National Institute for Clinical Excellence; 2004.

Scheffer IE, Berkovic SF, Capovilla G, Connolly MB, Guilhoto L, Hirsch E, Moshe SL, Nordli D, Zhang Y, Zuberi SM. The Organization of the Epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology. 2017.

Tirado Requero P, M. Alba Jiménez Servicio de Neurología infantil del Hospital Universitario La Paz, Madrid."Epilepsia en la infancia y la adolescencia". *Pediatr Integral* 2015; XIX (9): 609-621.

Vegiotti P, Beccaria F, Gatti A, Papalia G, Resi C. Can protrusion of the tongue stop seizures in rolandic epilepsy? *Epileptic Disord* 1999;1:217-20.

Wilfong A. Epilepsy syndromes in children. *Up To Date* 2015.

Wilmschurst JM, Gaillard WD, Vinyan KP, Tsuchida TN, Plouin P, Van Bogaert P, Carrizosa J, Elia M, Craiu D, Jovic NJ, Nordli D, Hirtz D, Wong V, Glauser T, Mizrahi E M, Cross J H. Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task Force Report for the ILA. *Epilepsia*. 2015; 56: 1185-97.

Xiao F, Lei D, An D, Li L, Chen S, Chen F, et al. Functional brain connectome and sensorimotor networks in rolandic epilepsy. *Epilepsy Res* 2015;113:25.

* Dr. Mauricio Tomás Pedersoli Castellani

Especialista en pediatría y neurología pediátrica. Docente en Cátedra de neurología en la UNLP. Neurólogo Servicio de neurología infantil del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Director de Centro interdisciplinario especializado en neurociencias y nutrición (CIENN), Agosto 2017.

INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS.

GENERALIDADES Y ASPECTOS CLÍNICOS PARA EL RECONOCIMIENTO



DR. MATÍAS OLEASTRO*

Sumario

Con el término de Inmunodeficiencias primarias se engloban unas 404 entidades. Si bien son enfermedades poco frecuentes, tomadas cada una de ellas individualmente, su prevalencia global es estimada en 1 en 1000 a 5000. Es importante el análisis anticipatorio de las manifestaciones clínicas que desarrollan los individuos con IDPs para su rápida presunción y la derivación oportuna.

Introducción

Se denominan Inmunodeficiencias Primarias (IDPs) a un grupo de enfermedades generadas por alteraciones cuantitativas y/o funcionales de alguno/s de los componentes de la respuesta inmune. La deficiencia puede asentar en uno o más de uno de los componentes del sistema inmune: linfocito T, linfocito B, linfocitos NK (Natural Killer), Sistema Fagocítico (neutrófilo, monocito, histiocito, célula dendrítica, etc.), Sistema Complemento y/o células reguladoras.

A diferencia de las Inmunodeficiencias Secundarias, en las IDPs no existe ningún factor o condición externa al sistema inmune que afecte su competencia. Se trata en la amplia mayoría de los casos de enfermedades monogénicas, es decir, que obedecen a la presencia de variantes génicas patológicas (mutaciones) en genes que codifican para proteínas que hacen a la integridad del sistema inmune, tanto en su estructura,

como en su correcto funcionamiento.

Hoy en día bajo el término de IDPs se engloban unas 404 entidades. Si bien son enfermedades poco frecuentes, tomadas cada una de ellas individualmente, su prevalencia global es estimada en 1 en 1000 a 5000.

En los últimos años se ha avanzado enormemente en el reconocimiento de los defectos moleculares y genéticos responsables de muchas de ellas y se han identificado alteraciones en unos 430 genes.

Las IDPs se clasifican y reagrupan periódicamente en función de los conocimientos nuevos que van surgiendo. La última revisión y puesta al día (Clasificación de las Uniones Internacionales de Inmunología del año 2019) agrupa o clasifica a estas 404 entidades de la siguiente manera:

- ✓ Inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral = Inmunodeficiencias combinadas (IDC)
- ✓ Inmunodeficiencias combinadas con un cuadro sindrómico asociado
- ✓ Deficiencias predominantes de anticuerpos
- ✓ Enfermedades por desregulación inmune
- ✓ Deficiencias congénitas del número o función del fagocito
- ✓ Defectos de la inmunidad innata
- ✓ Desórdenes autoinflamatorios
- ✓ Deficiencias del sistema complemento
- ✓ Fallas de médula ósea

- ✓ Fenocopias de errores congénitos de la inmunidad

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que desarrollan los individuos con IDPs que deben ser identificadas para establecer la presunción diagnóstica?

Sin lugar a dudas el rasgo más característico de estas enfermedades es la gran susceptibilidad para desarrollar infecciones. Sin embargo, cada vez es reconocida la fuerte asociación de manifestaciones que resultan de procesos autoinmunes, inflamatorios y/o linfoproliferativos. Mucho menos frecuente también podría nombrarse a las manifestaciones de alergia, especialmente de atopía.

En un 70 a 80 % de los casos las manifestaciones clínicas comienzan a hacerse evidentes o desarrollarse en edades pediátricas, especialmente antes de los primeros cinco años de vida.

Describiremos detalles de estas manifestaciones clínicas, cuya correcta identificación permitirá establecer un diagnóstico presuntivo y con ello, dar inicio al abordaje diagnóstico con los correspondientes exámenes complementarios (futuras publicaciones).

Infecciones

Representan el rasgo más característico en lo que respecta a la clínica. Suelen observarse en el 80 – 90 % de los casos. Estos procesos infecciosos pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, en un sólo sitio o en varios simultáneamente. Por lo general suelen:

Repetirse con mayor frecuencia de lo esperable (recurrencia)

Presentar mayor duración (persistencia, cronicidad)

Evolucionar tórpidamente (persistencia, cronicidad sin resolución clínica)

Presentar mayor gravedad clínica de lo esperable

Demostrar cierta refractariedad a los tratamientos bien instituidos

Desarrollar fácilmente complicaciones

Condicionar secuelas permanentes en los órganos o tejidos afectados

Los microorganismos responsables de las in-

fecciones pueden ser gérmenes habituales (Neumococo, Estreptococo, Estafilococo, Moraxella catarralis, etc.), gérmenes oportunistas (CMV, Herpes simple, Pneumocystis j., Candidiasis, Aspergilosis, Histoplasmosis, Toxoplasmosis, Nocardiosis, etc.), gérmenes de amplio espectro en un mismo paciente (infecciones por diferentes bacterias, virus, hongos y/o parásitos) o de espectro muy restringido y acotado (infección, en un individuo, sólo por HPV o por BCG, EBV, Neumococo, etc.).

En determinados casos la infección puede estar causada por un agente vacunal. Ejemplos de ello pueden ser la Meningoencefalitis o mielitis por Poliovirus tras la aplicación de vacuna OPV, una infección locoregional deltoidea - axilar (BCG-itis) o diseminada (BCG-osis) tras la aplicación de la vacuna BCG o una infección diseminada por virus de la Varicela.

Comentario: Si las infecciones se observan en un 80 – 90 % de los casos significa que existe un 20 a 10 % de pacientes con IDPs que nunca desarrollan las mismas. Es decir, se puede ser portador de una determinada IDP y no desarrollar infecciones y el estado de IDP manifestarse clínicamente por uno o más de los procesos que pasamos a describir a continuación.

Manifestaciones por autoinmunidad

Se entienden por manifestaciones autoinmunes aquellas generadas por el accionar de linfocitos T y/o linfocitos B autorreactivos, es decir linfocitos que reaccionan directamente o mediante sus productos (anticuerpos) contra antígenos tisulares propios.

Hoy en día se encuentra bien establecido y definido que los individuos con IDPs presentan un riesgo aumentado (globalmente mayor a 10 veces en comparación a la población general) para desarrollar fenómenos o manifestaciones autoinmunes.

Las posibles manifestaciones o situaciones autoinmunes observadas en estos pacientes son las siguientes:

- ✓ Citopenias hemáticas: Anemia hemolítica, Trombocitopenia, Neutropenia. Las mis-

mas se pueden desarrollar aisladamente o asociadas, es decir como Síndrome de Evans.

- ✓ Enfermedad celíaca con su cuadro sintomático
- ✓ Vaculitis de diferentes localizaciones
- ✓ Enteropatía (diarrea)
- ✓ Gastritis atrófica
- ✓ Hepatitis
- ✓ Colangitis
- ✓ Endocrinopatías: Tiroiditis, Diabetes Mellitus tipo 1, Enfermedad de Adisson, hipoparatoroidismo, etc.
- ✓ Manifestaciones cutáneas: Alopecia, Vitiligo, Pénfigo, urticaria
- ✓ Cuadro sindromático de Lupus Eritematoso Sistémico
- ✓ Uveitis anterior aguda
- ✓ Glomerulonefritis
- ✓ Manifestaciones de Mitenia gravis

Las citopenias hemáticas (anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia autoinmune, ya sea en forma evolutiva o simultánea) representan las manifestaciones autoinmunes mayormente observadas y reportadas.

Cualquiera de estas manifestaciones autoinmunes puede ser la primera en desarrollarse y presentarse en un paciente con IDP, y esta manifestación puede mantenerse en forma asilada (sin otras) durante mucho tiempo. Esto hecho puede condicionar que la consulta clínica inicial se realice directamente en una determinada especialidad (ej. Hematología, Gastroenterología, Neumología, Endocrinología, etc.). Esto implica, por un lado, que toda especialista debe valorar esta posibilidad (la importancia de incorporar el abordaje de estas patologías en los programas de capacitación y actualización de Especialidades), y, por otro, la necesidad de una actividad asistencial interdisciplinaria adecuada para su correcto abordaje diagnóstico y posteriormente, terapéutico.

Fortalece la sospecha de una IDP subyacente si la manifestación autoinmune se presenta:

- ✓ En forma múltiple, es decir 2 o más manifestaciones autoinmunes en forma simultánea o evolutivas,
- ✓ Con evolución tórpida, recurrente o crónica,
- ✓ Sin mejorar bajo un tratamiento correctamente indicado,

- ✓ Asociada a otras manifestaciones (infecciones, inflamación, linfoproliferación)
- ✓ También en otro familiar directo.

Manifestaciones por inflamación

Se entienden por manifestaciones inflamatorias aquellas que se generan como consecuencia de una desregulación de los mecanismos inflamatorios que normalmente genera y controla el sistema inmune innato (neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, interleuquinas, interferones, etc.).

Para este tipo de manifestaciones caben los mismos comentarios referidos en autoinmunidad. Es decir, el mayor riesgo a desarrollar manifestaciones o procesos inflamatorios, ya sea en un tejido u órgano en particular como en forma sistémica, en pacientes con IDP que el esperable en la población general. De la misma forma también las consideraciones en cuanto a que una determinada manifestación inflamatoria puede presentarse inicialmente en forma asilada y mantenerse como tal durante un largo periodo y ello condicionar una consulta médica directa en especialista (Gastroenterología, Neumología, Dermatología, etc.).

Las posibles manifestaciones o situaciones inflamatorias que pueden ser observadas en el contexto de una IDP son las siguientes:

- ✓ Fiebre
- ✓ Diarrea (por Enfermedad inflamatoria intestinal)
- ✓ Aftas – úlceras cutáneas y/o mucosas
- ✓ Eccema – Dermatitis eczematosa
- ✓ Edema subcutáneo - angioedema
- ✓ Eritrodermia – exantemas – rash
- ✓ Vasculitis – vasculopatías
- ✓ Artritis - sinovitis
- ✓ Pioderma gangrenoso – granulomas estériles
- ✓ Psoriasis – Dermatitis psoriasiforme
- ✓ Pitiriasis Rubra Pilaris
- ✓ Acné
- ✓ Serositis (Pleuritis, pericarditis, peritonitis)
- ✓ Enfermedad pulmonar intersticial
- ✓ Osteomielitis focal o múltiple
- ✓ Uveítis, corioretinitis
- ✓ Parotiditis recurrente
- ✓ Compromiso inflamatorio meníngeo, encefálico, etc.

Fortalecen la sospecha de una IDP de base si la manifestación o condición inflamatoria se presenta:

- En forma múltiple, es decir varias condiciones inflamatorias al mismo tiempo o en forma evolutiva en el mismo paciente.

- Asociada a infecciones (con las características ya mencionadas), a manifestaciones autoinmunes y/o linfoproliferativas.

- Si no resuelve bajo un tratamiento correctamente indicado.

- En otro miembro familiar directo.

Linfoproliferación

Se entiende como manifestación linfoproliferativa toda aquella generada por un proceso de proliferación de células linfoides sostenido en el tiempo.

Así podemos considerar a la/s adenomegalia/s, la esplenomegalia, el agrandamiento de componentes del anillo de Waldeyer o, a masas linfoides desarrolladas en diferentes localizaciones viscerales (ej. Digestivas, SNC, etc.).

En cuanto a la caracterización, esta proliferación linfoidea podrá ser:

- ✓ Benigna de linfocitos T o linfocitos B:
- ✓ Policlonal
- ✓ Oligo/monoclonal
- ✓ Leucemias T, B, NK
- ✓ Linfomas Hodgkin, No Hodgkin

Si bien como manifestación aislada no debería considerarse fuertemente orientadora de IDP, fortalecen las posibilidades de que de eso se trate si la linfoproliferación se presenta:

- Asociada a infecciones, manifestaciones autoinmunes y/o inflamatorias (con todas las consideraciones ya descriptas)

- Con una evolución persistente/crónica

- Se documenta una estrecha relación con el virus de Epstein Barr

- Con el antecedente de otro miembro familiar directo con cuadro similar

Hipersensibilidad / Atopía

Se ha documentado que aproximadamente entre un 20 y 30 % de los pacientes con IDP manifiestan algún tipo de hipersensibilidad.

Así podemos observar:

- ✓ Dermatitis tipo atópica
- ✓ Urticarias
- ✓ Asma, rinitis

- ✓ Diarrea, vómitos, dolor abdominal (alergias alimentarias)
- ✓ Anafilaxia inducida por transfusión de hemoderivados

Debido a que las manifestaciones atópicas o de hipersensibilidad son frecuentes en la población general, la sospecha de una IDP de base estará condicionada por la presencia o no de las siguientes situaciones:

- Asociación con infecciones, manifestaciones autoinmunes, inflamatorias y/o linfoproliferativas.

- Una evolución o comportamiento severo, con franca refractariedad a los tratamientos indicados.

- Antecedente de familiar directo con cuadro clínico semejante.

Manifestaciones no inmunológicas

Numerosas IDP pueden presentar manifestaciones o signos clínicos que no se encuentran condicionados por la alteración inmune en sí. En algunos casos corresponden a hallazgos aislados, mientras que en otros conforman parte de un cuadro sindrómico bien definido (patrón de malformaciones o apariencias con relación patogénica).

Algunos ejemplos:

Alteraciones estructurales del desarrollo

Dismorfias/apariencias faciales

Dismorfias corporales (incluyendo microcefalia, estatura corta, etc.)

Anomalías oculares (coloboma, cataratas, distrofia retinal, etc.)

Alteraciones dermatológicas

Telangiectasias óculo cutáneas

Máculas/líneas coloreadas - pigmentadas

Displasia ectodérmica

Anhidrosis

Cabello- pelo plateados/gris

Cabello-pelo escaso y fino

Cabello -pelo Bamboo ("invaginado")

Anomalías o distrofias de las uñas.

Alteraciones de la dentición

Hipodontia

Dientes cónicos

Retención primaria

Alteraciones esqueléticas

Displasias óseas

Hiperlaxitud ligamentaria

Escoliosis

Cardiopatías congénitas Aneurismas coronarios, cerebrales Atresia intestinal única o múltiple

Si bien todas ellas pueden presentarse sin estar asociadas o relacionadas a una situación de inmunodeficiencias primaria, en ciertos estos hallazgos sí lo están.

Fortalecerán la sospecha de una IDP de base o asociada si estas manifestaciones o hallazgos se presentan:

- Asociados a infecciones, autoinmunidad, inflamación y/o linfoproliferación.
- En un familiar directo con un cuadro semejante (inmunológico y no inmunológico).

Estas manifestaciones o hallazgos pueden ser detectados precozmente, incluso antes que otras manifestaciones generadas por la inmunodeficiencia se hagan evidentes (las arriba referidas). Su identificación debe motivar una valoración clínica más amplia del paciente que debe incluir un abordaje con estudios inmunológicos de primera línea.

Resumiendo

Las IDPs son un conjunto de enfermedades, cada vez mayor, de enfermedades congénitas y hereditarias, por lo tanto, con la posibilidad de afectar a más de un miembro de la familia, que se desarrollan sus primeras manifestaciones clínicas en edades pediátricas.

Las manifestaciones clínicas frecuentemente observables en estos pacientes obedecen a infecciones, autoinmunidad, inflamación y/o linfoproliferación. La identificación de las mismas debe motivar en el médico clínico o especialista la presunción diagnóstica y con ello, una estrategia diagnóstica utilizando los exámenes complementarios adecuados.

A fin de evitar retrasos diagnósticos y con ello, indicaciones terapéuticas tardías responsables de evoluciones tórpidas o recurrentes (condicionantes de secuelas o morbilidades), se aconseja el trabajo interdisciplinario con un oportuno acompañamiento por especialistas en estas patologías.

Bibliografía

- Bousfiha, A., Jeddane, L., Picard, C., Al-Herz, W., Ailal, F., Chatila, T., Klein, C. (2020). Human inborn errors of immunity: 2019 update of the IUIS phenotypical classification. *Journal of Clinical Immunology*, 1-16.
- Fischer, A., Provot, J., Jais, J. P., Alcais, A., Mahlaoui, N., Adoue, D., Bader-Meunier, B. (2017). Autoimmune and inflammatory manifestations occur frequently in patients with primary immunodeficiencies. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 140 (5), 1388-1393.
- Herber, M., Mertz, P., Dieudonné, Y., Guffroy, B., Jung, S., Gies, V., Guffroy, A. (2020). Primary immunodeficiencies and lymphoma: a systematic review of literature. *Leukemia & Lymphoma*, 61 (2), 274-284.
- Martínez-Valdez, L., Deyà-Martínez, A., Giner, M. T., Berrueta, R., Esteve-Solé, A., Juan, M., Alsina, L. (2017). Evans syndrome as first manifestation of primary immunodeficiency in clinical practice. *Journal of pediatric hematology/oncology*, 39 (7), 490-494.
- Ming, J. E., Stiehm, E. R. (2017). Syndromic immunodeficiencies. In *Primary Immunodeficiency Diseases* (pp. 519-551). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Reyes, S. O. L., Ramírez-Vázquez, G., Hernández, A. C., Medina-Torres, E. A., Ramírez-Lopez, A. B., España-Cabrera, C., Murata, C. (2016). Clinical features, non-infectious manifestations and survival analysis of 161 children with primary immunodeficiency in Mexico: a single center experience over two decades. *Journal of clinical immunology*, 36 (1), 56-65.
- Routes, J. M., Verbsky, J. W. (2017). Immunodeficiency Presenting as an Undiagnosed Disease. *Pediatric clinics of North America*, 64 (1), 27-37.
- Schmidt, R. E., Grimbacher, B., Witte, T. (2018). Autoimmunity and primary immunodeficiency: two sides of the same coin?. *Nature Reviews Rheumatology*, 14(1), 7.
- Tangye, S. G., Al-Herz, W., Bousfiha, A., Chatila, T., Cunningham-Rundles, C., Etzioni, A., Ochs, H. D. (2020). Human inborn errors of immunity: 2019 update on the classification from the international union of immunological societies expert committee. *Journal of Clinical Immunology*, 40(1), 24-64.
- Vincent, S. F., Casady, M., Chacon, A., Gaspari, A. A. (2018). Skin Diseases in Primary Immunodeficiencies. In *Skin Diseases in the Immunosuppressed* (pp. 35-51). Springer, Cham.

*Dr. Matías Oleastro

Jefe de Clínica Médica en Inmunología. Servicio de Inmunología y Reumatología. Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Juan P. Garrahan".

correo: moleastro@yahoo.com.ar

ENTREVISTA EN EL ADOLESCENTE



DR. PABLO GABRIEL DEI-CAS*

Sumario

Herramientas elementales desde la comunicación y la semiología, tendientes a una adecuada calidad en la atención de los, las y les adolescentes. Peculiaridades de la entrevista.

Juana y Benjamín de 12 y 14 años respectivamente concurren a la consulta.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a dos adolescentes, ¿qué debemos tener en cuenta como Pediatras para poder brindarles una atención de calidad?

- ✓ ¿Qué es la adolescencia?
- ✓ ¿Qué tipo de adolescente puede llegar a la consulta?
- ✓ ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos?
- ✓ ¿Deben concurrir acompañados?
- ✓ ¿Qué característica tiene la entrevista adolescente?
- ✓ ¿Qué debe garantizarse?
- ✓ ¿Cuánto debe durar la entrevista?
- ✓ ¿Cómo debe iniciarse la entrevista?
- ✓ ¿Cuál es la primera pregunta?
- ✓ ¿Qué tipo de preguntas conviene utilizar?
- ✓ ¿Qué ítems indagaría?
- ✓ ¿Cómo continuaría luego de finalizadas las preguntas?
- ✓ ¿Cómo cerraría la consulta? ¿Qué tendría en cuenta en esta instancia?

La adolescencia, período que transita entre los 10 y 21 años de edad, constituye un proceso dinámico en la vida del ser humano, ya que ocurren rápidos cambios en los aspectos físico,

psíquico, social y espiritual. Como refiere Dina Krauskopf, “es una etapa en sí misma”.

El impacto que genera cada uno de ellos difiere de un sujeto a otro, por lo que debemos estar preparados para dar respuesta a diferentes formas de presentación de la problemática de este grupo etario.

Hay que tener en cuenta que los adolescentes pueden presentar distintos temperamentos, pudiendo arribar a la consulta con deseos de hablar, silenciosos, enojados y agresivos, o llorosos. Hay que tener en cuenta que, muchas veces, son traídos por un adulto que detecta un problema donde ellos no lo perciben.

Más allá de las características del adolescente, con el fin de brindarle una atención de calidad debemos mantener una identidad adulta, ser pacientes, demostrar interés y preocupación por la situación que motiva su visita, sin minimizar sus preocupaciones. Por otro lado, resulta imprescindible ser conscientes de usar con ellos un lenguaje simple, que sea comprensible, evitando tecnicismos. Al mismo tiempo es de relevancia que conozcamos su léxico, no para utilizarlo en la entrevista, sino para entenderlos mejor. No debe pasársenos por alto que no tenemos que ponernos a la altura del adolescente. Ese adolescente no necesita otro adolescente o un amigo, va en busca de un adulto que lo escuche, que le dé apoyo y lo acompañe en la toma de decisiones. Subestimar este aspecto puede hacer peligrar el vínculo posterior. Al atenderlos hay que procurar hablar poco, no emitir juicios de valor, principalmente escuchar considerando que casi nunca van a buscar un consejo sino que concurren para que “les prestemos la oreja”, y

más aún, observar (expresión, movimientos, actitud, mirada, vínculo con quien lo acompaña o con nosotros).

Hay que considerar que puede consultar acompañado (familiares, amigos, pareja) o concurrir solo. El hecho de no brindarle la atención que demanda, en caso de llegar solo al consultorio constituye una ilegalidad, teniendo en cuenta su condición de sujeto de derecho al que debe garantizársele el acceso a la salud. Por lo tanto, es nuestra obligación brindarle la debida atención, independientemente de si se presenta solo o en compañía de terceros. La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 12 que *“Los Estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez”*. Tal como se expresara previamente, los niños y adolescentes son sujetos de derechos que van adquiriendo cada vez más capacidad para el ejercicio de los mismos, constituyéndose lo que se conoce como “autonomía progresiva”. El desconocimiento o la omisión de estos conceptos van a llevarnos a cometer un acto ilegal, en caso de negarles a los adolescentes la atención que solicitan.

En función de esto último, la entrevista adolescente va a llevarse a cabo en una o dos etapas: una con el adolescente a solas, y otra con el adolescente y su familia, debiendo ser previamente informadas ambas partes acerca de la dinámica de la misma. Cabe jerarquizar lo trascendente de aclarar que, de tratarse de una consulta de primera vez, se hace primero la entrevista con el adolescente en presencia del adulto acompañante. Resulta importante remarcar el hecho de no menospreciar la participación de ese adulto, ya que nos permite recabar antecedentes familiares y del paciente desde el nacimiento que pueden resultar fundamentales, para luego, si el adolescente lo considera válido, tener la entrevista a solas.

Antes de iniciarse la entrevista debe aclararse tanto al adolescente como a la familia aspectos concernientes a la confidencialidad y al secreto médico, lo cual implica que lo que surja de ella no será revelado, quedando lo expresado entre el paciente y el profesional. Solo en situaciones de riesgo para el paciente se le pedirá su consentimiento para develarlo a quien él nos

indique. Esto hará posible que el paciente se exprese más libremente y pueda exponer su problemática sin ocultamientos, y el adulto que lo trae a la consulta deposite su confianza en el profesional.

La ley 26.529 reconoce como esencial el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. El Código Penal criminaliza revelar el secreto profesional si se hace sin justa causa. Sin embargo, por otro lado, debe informárseles además que existen excepciones que nos permiten romper el secreto médico, las cuales incluyen la presencia de situaciones de riesgo inminente para la vida del adolescente o de terceros, o en caso de solicitud de la historia clínica por medio de una orden judicial. La ley 17.132 establece que la información podrá brindarse solamente para evitar un mal mayor. En caso de detectarse algún evento de riesgo debe consensuarse con el adolescente a qué adulto responsable de su confianza comunicar la problemática y acordar la forma de llevarlo a cabo. Se debe aguardar el consentimiento del paciente para dar la información, salvo que la situación apremie.

A diferencia de lo que puede ocurrir con pacientes de menor edad, se requiere más tiempo para entrevistar al adolescente. Son necesarios entre 30 y 45 minutos, sin olvidar de adaptar las preguntas a la edad cronológica, a la etapa evolutiva y al desarrollo emocional y cognoscitivo del sujeto que consulta.

En primer término, antes de dar comienzo a la entrevista, debemos presentarnos cordialmente. Acto seguido vamos a preguntarle al adolescente cómo quiere ser llamado (importante desde el género) y su edad y, en caso de haber asistido acompañado por miembros de la familia, indagar acerca del rol que cumple cada uno de ellos.

Una vez recabados estos datos se interrogará acerca del motivo de consulta, el cual puede ser una situación patológica o un control de salud en el que quizás solicite únicamente la confirmación de la normalidad de los cambios corporales adquiridos. En caso de concurrir el adolescente en compañía, debemos tener en cuenta que el motivo de consulta puede diferir. Es nuestro deber, en este caso, escuchar a todas las voces intervinientes sin “perder de vista” al adolescente. Por otro lado, además, debemos saber que detrás de un motivo de consulta manifiesto puede haber uno o más ocultos. Poderlo entrever, es

nuestro mayor desafío.

Más allá de tratarse o no de la primera pregunta, resulta provechoso que las preguntas que le formulemos sean abiertas, que le permitan expresarse en el tema que le preocupa. En ocasiones resulta de utilidad utilizar las respuestas “en espejo” (repetir su respuesta), ya que producto de ellas probablemente el adolescente continúe explicando. Conviene, además, durante el transcurso de la entrevista, aclarar cuestiones complejas, resumir para desechar lo accesorio, y procurar dejar para lo último los temas espinosos.

Aparte del motivo de consulta, recabaremos información a través de diferentes preguntas que se harán al paciente y a sus padres (si concurre acompañado) que abarcan una serie de temas importantes que seguidamente se detallan:

- Desarrollo físico y cambios corporales:

a) Preguntar al adolescente: Si tiene alguna duda respecto a su crecimiento y desarrollo sexual. Qué opina de su cuerpo.

b) Preguntar a los padres: Si algo les preocupa en relación al tema en cuestión.

- Nutrición y hábitos alimentarios:

a) Preguntar al adolescente: Qué come. Si consume comida “chatarra”. Cuántas comidas hace, con quién y dónde come. Si come solo cuando tiene hambre o si lo hace por ansiedad.

b) Preguntar a los padres: Si están conformes con la alimentación de su hijo.

- Hábitos evacuatorios: Indagar acerca de las características de la diuresis y la catarsis.

- Sueño: Interrogar si duerme bien o le resulta difícil conciliar el sueño, y qué hace para salvar esta situación. Si se despierta por la noche. Si presenta pesadillas. Cuántas horas duerme. A qué hora se acuesta y a qué hora se despierta. Con quién y dónde duerme.

- Conductas y desarrollo socioemocional: a) Autoestima: Preguntar si está conforme con su forma de ser, con su apariencia. Indagar acerca de su estado anímico, si en algún momento intentó suicidarse, si piensa en morirse. b) Capacidad de expresar los sentimientos y buscar la ayuda de un adulto en caso de resultar necesario: Con quién charla de sus problemas. Cómo define su carácter. c) Autonomía: Si viaja solo. Si se compra solo lo que necesita. Si dispone de dinero y quién se lo otorga. d) Recursos personales y presión del grupo de pares: Si tiene amigos. Qué actividades hacen para divertirse. Si se siente a gusto o presionado por ellos.

- Recreación: Con qué se entretiene. Cuántas horas pasa frente a la TV o los videojuegos. Si usa dispositivos móviles y durante cuánto tiempo. Si utiliza las redes sociales y si alguna vez vivió algún momento desagradable o de violencia al momento de usarlas. Si tiene algún hobby. Si le agrada la lectura y qué tipo de obras literarias prefiere. Si practica deportes, cuáles, y si toma las medidas correspondientes para prevenir la aparición de lesiones. Qué música escucha, y si va a bailar qué lugares frecuenta, ya que nos puede dar una idea de consumos.

- Escolaridad y trabajo: Interrogar si estudia. Qué grado o año cursa. Cómo es su rendimiento escolar. Si presenta dificultades en el aprendizaje y, de ser así, en qué materias. Si repitió algún grado, cuál fue y porqué, si en algún momento ha habido deserción escolar y su causa. Si cursa estudios terciarios o universitarios qué carrera eligió, qué año transita, si está conforme con la misma y si su rendimiento es satisfactorio. Si tiene algún estudio no formal o actividad grupal y cuál. Si trabaja. En qué. Desde cuándo. Cuánto tiempo por semana. Por qué motivo. Si fue obligado a hacerlo.

- Consumo: Tabaco, alcohol y drogas: Debe ser interrogado con el paciente a solas y cuando la situación lo permita: Si fuma. Qué fuma. Desde cuándo. Si en alguna oportunidad lo hizo con cigarrillos electrónicos. Si lo hace solo o acompañado. Cuántas veces por semana. Si se lo comentó a sus padres o a algún adulto de confianza. Ídem para alcohol y drogas.

- Salud sexual y reproductiva: Evaluar el momento oportuno para indagarlo, considerando las características personales de cada paciente. Muchas veces no resulta prudente llevarlo a cabo en la primera entrevista. Tiene que ser efectuado con el paciente a solas: Preguntar a mujeres y varones: Si conoce nombre y función de sus genitales. Si se masturba. Si le gusta algún chico o chica. Si tiene pareja (sin dar por sobreentendido el uso de la palabra novio en caso de tratarse de una chica y novia de tratarse de un varón, ya que la pareja puede ser hetero, homo ó bisexual). Si ha iniciado relaciones sexuales, a qué edad. Si participó siempre la misma pareja o fueron múltiples. Si fue obligado a hacerlo. Si resultó placentero. Si utilizó preservativo para evitar ITS y embarazo y en qué medida (nunca, ocasionalmente, siempre) Si le explicaron la forma correcta de colocación. Si no usó o de haber-

se hecho de manera discontinuada, porqué. Si conoce las ITS. Si en algún momento contrajo alguna. Si ha tenido hijos o algún aborto. Si en alguna oportunidad sufrió alguna forma de abuso y, en caso afirmativo, cuál. Si es mujer: Edad de la menarca. Cuándo fue la última menstruación. Si los ciclos son regulares y su duración. Si tiene o ha presentado flujo, sus características. Si ha tenido embarazos, si sospecha que puede estar embarazada actualmente o abortos. Si en alguna ocasión concurre a control ginecológico. Si conoce los métodos anticonceptivos. Si utilizó alguno o desea hacerlo desde el momento actual. Cuál usó, y quién se lo indicó. Si alguna vez usó la pastilla del día después, aprovechando el momento para informar acerca de su uso y para qué sirve. En caso de ser varón: Si ya tuvo su primera polución. Explicar de qué se trata. Interrogar cuánto tiempo hace que ocurrió para conocer comienzo de su desarrollo. Si presentó descargas nocturnas de semen. Si constató secreción peneana y sus características. A los padres: Si conversaron de estos temas con sus hijos. Si necesitan información o ayuda para efectuarlo.

- Situación y dinámica familiar: Dónde y con quién vive. Quién trabaja en la casa y qué actividad desarrolla. Qué tipo de relación tiene con sus padres, hermanos u otros convivientes.

- Vivienda: Si dispone de servicios sanitarios, agua potable, luz eléctrica y heladera para conservación de los alimentos. Número de habitaciones. Si dispone de algún espacio donde pueda estar a solas, de ser necesario.

- Violencia familiar: en los vínculos con sus parejas, amigos o compañeros de clase. Qué tipo de violencia: verbal, física, ambas.

Una vez finalizada la entrevista, se llevará a cabo un examen físico completo explicando al adolescente los procedimientos a efectuar, el cual se realizará cada 6 meses hasta un año después de haberse producido el pico de empuje puberal, para pasar luego a un control anual. En el mismo se deberá incluir la evaluación de la maduración física a través de la visualización de los estadios de Tanner, siendo fundamental evaluar genitales femeninos, y masculinos con orquímetro, explicando por qué es importante evaluarlos a esta edad y darle la oportunidad de elegir el momento en que lo haremos. No debemos desaprovechar la oportunidad de brindarles la posibilidad del auto cuidado y la

auto inspección a las chicas de sus mamas, y a los chicos de sus testículos y pene. Recordar no omitir los exámenes bucodental, oftalmológico y auditivo. Se llevarán a cabo, además las mediciones antropométricas, el cálculo del índice de masa corporal, el registro de la presión arterial y la correspondiente percentilación de los mismos, como así también el control del esquema de vacunación, jerarquizando lo importante de indicar a toda la vacuna contra el HPV, aunque hayan superado la edad para su aplicación. Se solicitarán exámenes complementarios: laboratorio completo incluyendo perfil tiroideo, colesterolemia, hepatograma completo, Rx de tórax, Rx de columna (en caso de considerarse necesario); e interconsultas en caso de haberse detectado algún evento anómalo o de haber surgido algún antecedente personal o familiar de riesgo. Cabe destacar que se derivará al paciente al odontólogo una vez al año, al oftalmólogo en algún momento de la adolescencia, y al ginecólogo en las adolescentes que ya iniciaron su actividad sexual, luego de 18 meses a 2 años de su primera relación sexual o en caso de presentar patología que no se pueda resolver desde la clínica.

Una vez culminada su revisión clínica procederemos a indicarle los pasos a seguir en caso de haberse encontrado alguna patología ó situación preocupante, lo cual deberá efectuarse en forma oral y escrita, sin olvidar de hacerlo con letra clara, confirmando posteriormente su comprensión. Más allá de esto, tenemos que indagar acerca de dudas (lo cual se realizará en varias oportunidades por temor a que las mismas no se expresen en una primera instancia por vergüenza o pudor), haciéndolo extensivo no solo al paciente sino también a sus padres, si asistió a la consulta acompañado. No debemos perder la oportunidad en el cierre de la entrevista de destacar sus cualidades positivas, desalentando las conductas inadecuadas, jerarquizando sobremanera la importancia de la Prevención y Promoción de la Salud. Es nuestro compromiso la búsqueda de estrategias anticipatorias para tratar de evitar al máximo posible la aparición de situaciones indeseables para el adolescente y su entorno; y un desafío la habilidad para no agotar la totalidad de los temas en una consulta, dejando algo pendiente para una próxima visita.

Bibliografía

- Casa Rivero J, Iglesias Diz J. La entrevista al adolescente. *Adolescere. Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Volumen III. Mayo 2015. N°2.*
- Hidalgo Vicario M, Castellano Barca G. Entrevista con adolescentes. ¿Cómo afrontar con seguridad la entrevista clínica con adolescentes? En AEPap ed. *Curso de actualización Pediatría 2003. 1ra. Ed. Madrid Exlibris Ediciones 2003; p 261-267.*
- López Navarrete G, Perea Martínez A, Padrón Martínez M et al. Entrevista con el adolescente. *Acta Pediat Mex 2014; 35: 229-237.*
- Ministerio de Salud de la Nación. Comité de Estudios Permanentes de Adolescencia Sociedad Argentina de Pediatría. *Guía de recomendaciones para la Atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad. Los derechos en juego en la consulta con adolescentes, pág.20. La consulta con adolescentes, pág.34. Noviembre y diciembre de 2010.*
- Sociedad Argentina de Pediatría. Comité de Estudios Permanentes del Adolescente. *La entrevista con adolescentes. Encuentro Moreno. Mayo de 2009.*
- Sociedad Argentina de Pediatría. Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria. *Manual para la Supervisión de la Salud de niños, niñas y adolescentes. Adolescentes, pág. 237. FUNDASAP Ediciones, 2010.*

*Dr. Pablo Gabriel Dei-Cas

Jefe del Servicio de Pediatría del HIGA Presidente Perón de Avellaneda. Instructor de Residentes.
Docente Adscripto UBA.

Comentario Final por Dra. Teresa D'Orsi

Si partimos de la premisa que la SALUD ES UN DERECHO HUMANO. Para todos los que estamos en el trabajo cotidiano con y para los adolescentes sabemos que en la práctica existen barreras de acceso de adolescentes al sistema de salud. Esas "barreras" se fundamentan, entre otras, en el desconocimiento, por parte de los equipos, de los marcos jurídicos y legales que garantizan este derecho al acceso. ¿Pueden ir los adolescentes solos a la consulta? ¿Puedo tener un problema legal por atenderle sin sus padres o madres? ¿Para recibir métodos anticonceptivos, hay una edad establecida? ¿Qué debo denunciar en forma obligatoria? Estas preguntas, surgen en la consulta diaria forjando temores que hacen que nuestros adolescentes sean eyectados de los servicios de salud.

Tenemos un frondoso Marco Jurídico que nos respalda para garantizar el Ejercicio de los derechos a la Salud de nuestra población adolescente. Por eso me pareció oportuno llevar algunas reflexiones sobre estas leyes de manera que pueda impactar en una mejor atención de Niños, niñas y Adolescentes (NNy A).

A partir de "La Convención de los Derechos del Niño" "año 1994 hay un cambio absoluto en tanto se reconocen a NNy A como SUJETOS DE DERECHO. El Art. 12 y 13 de esta Convención prioriza el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, es decir que, mediante una buena información pueda ejercer su derecho acorde a la Autonomía Progresiva (que no tiene que ver con la edad cronológica). Esa Autonomía Progresiva es el reconocimiento jurídico a la capacidad progresiva de discernimiento y el respeto a esta autonomía impone la obligación de atender las consultas de menores de 18 años, con o sin acompañantes.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Así como lo define el art. 3 de la Ley Nacional de Protección Integral de los NNyA (Ley N° 26.061), es un conjunto de acciones enfocadas en garantizar el desarrollo integral y una vida digna.

Tenemos la Ley de Atención Integral de los Adolescentes, (Ley N° 26061) que enmarca la atención interdisciplinaria e intersectorial (con familia, escuela etc.) promoviendo todas las acciones de prevención, promoción de la salud con toda la información precisa.

La Ley N° 26.529 de Paciente, Historia Clíni-

ca y Consentimiento Informado, en su art. 2 inc. a, reconoce que: TODO/A NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE QUE SE PRESENTE AL SERVICIO DE SALUD SIN ACOMPAÑAMIENTO DEBE SER ATENDIDO/A.

Derecho a la privacidad y a la protección de la información no es más que el secreto médico y la confidencialidad. Significa que: les profesionales de la salud tienen el deber ético y jurídico de guardar el “secreto profesional”.

DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

La Ley 26.743 de Identidad de Género (LIG), reglamentado por el Art.11 de la misma ley reconoce el derecho a la reasignación de su identidad legal (nombre y sexo) a partir de cómo se auto perciba y acceder a tratamientos hormonales y cirugías que quisieran llevar a cabo para la modificación corporal. (Los remito a informarse acerca de Salud y adolescencias LGBTI. Herramientas de abordaje integral para equipos de salud. <https://bit.ly/2HV2ONP>)

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 25.673 tiene como objetivos, entre otros, promover la salud sexual de les adolescentes y garantizar el acceso a información, orientación, métodos ACO, prueba del VIH así como aborto seguro sin autorización de un adulto. Las consultas de NNyA por métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y/o preservativos son prestaciones de emergencia. Que cualquier integrante del equipo de salud puede proporcionar. Su entrega es en la demanda y no debe necesitar turnos previos, horarios de atención limitados, ni exámenes complementarios. También debe informarse y facilitarse métodos anticonceptivos de larga duración (DIU e implante subdérmico). En cuanto a Anticoncepción de Emergencia No existe ningún impedimento legal ni científico para impedir o retrasar el acceso inmediato a ella.

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE)

En Argentina, el aborto tiene causales establecidas en el art. 86 del Código Penal de la Nación: “riesgo para la salud o vida de la persona gestante o violación. A través del fallo “F., A.L. (2012)”,

No se requiere solicitar interconsultas.

- No corresponde pedir denuncia ni prueba de la violación.

- La práctica debe realizarse de forma rápida, accesible y segura

Todas las niñas y personas (con capacidad de gestar) menores de 13 años embarazadas podrán solicitar la interrupción legal de su embarazo ya que el derecho penal indica que ese embarazo es producto de una violación. En casos de mayores de 13 años, hará una declaración jurada donde afirme que ese embarazo es el producto de una violación. En los casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por peligro para la salud integral de NNyA se deberá consignar en la historia clínica el riesgo que implica, sea físico o psico-social, y cualquier profesional de la salud puede certificar la causal, (pediatra, ginecólogo, psicólogo, trabajador social). En el caso de haber conflicto entre su decisión y la opinión de un progenitor o adulto responsable se ejerce el derecho del Interés Superior del niño.

LA PARENTALIDAD ADOLESCENTE

El Código Civil y Comercial (art. 644) dice que: “los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos/as”. No es necesario que un adulto autorice el alta después de una internación o nacimiento de un niño/a hijo/a de padres/madres adolescentes. Importante, a la hora de un alta en nuestros servicios de pediatría, donde cada vez más, son padres adolescentes.

Espero que el traer a la memoria y a la reflexión este Marco Legal en la Atención Integral de los NNyA sea de utilidad en la práctica diaria. El objetivo es dar luz y seguridad a nuestro actuar en cada consulta. Y sentirnos con la satisfacción de garantizar los Derechos de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, que en muchos aspectos y aún hoy, están Vulnerados.

Dra. Teresa D’Orsi

Pediatra-Hebiatra.

Ex Jefa y Fundadora de la Unidad de Adolescencia HIGA Pte. Perón.

Miembro del Comité de Adolescencia de Sociedad Argentina de Pediatría CEPA-SAP.

LA CONSULTA Y EL EXAMEN GINECOLÓGICO EN LA NIÑA Y EN LA ADOLESCENTE



DR. PABLO GABRIEL DEI-CAS*

Sumario

Si bien nuestro objetivo es realizar un correcto examen del sistema reproductor, tanto el interrogatorio (a la madre, a la niña, o a la adolescente) así como el examen físico general, preceden en todas las etapas a la exploración localizada.

El objetivo de la consulta ginecológica en las diferentes etapas de la vida responde a:

- ✓ Dar atención al motivo que la genera
- ✓ Realizar una entrevista y un examen físico adecuados
- ✓ Aprovechar para realizar una consulta integral
- ✓ Ganar la confianza necesaria que permita el seguimiento posterior y las consultas periódicas a lo largo de su vida.

¿Por qué viene a la consulta una niña?

- a-derivada por el pediatra
- b-la trae la madre porque algo le preocupa
- c-la consulta es por crecimiento y desarrollo de la niña
- d-la niña es derivada desde el juzgado.

¿Cómo realizar la entrevista?

- Es fundamental generar tanto en la madre como en la niña, un clima de confianza y tranquilidad. Durante la primera infancia y hasta los 6-7 años cobra importancia la seguridad que el médico debe transmitir a la madre y la niña.
- “Clima de confianza y tranquilidad: no podemos atender a una niña y su madre

en un ambiente que sea pacible de ser interrumpido”,

- Explicar de antemano que nada de lo que se haga la va a dañar o a avasallar su pudor y siempre será con su consentimiento.
- Que es importante la colaboración de ambas para practicar el examen a fin de que no genere incomodidades.
- Los gestos adquieren preeminencia por sobre la comunicación verbal.
- Es conveniente hablar como un adulto y no imitando a un niño.
- Para las más chiquitas, es conveniente tener una muñeca sobre la cual se le explicará lo que se va a hacer.
- El pediatra debiera incorporar el examen de los genitales en forma rutinaria.
- No hay que desperdiciar la oportunidad para averiguar el cumplimiento del calendario de vacunación.
- Preguntar quién está a cargo de la niña la mayor parte del tiempo.
- Preguntar a cerca de cómo es la integración familiar.
- Es importante observar el vínculo existente entre ambas. (Cómo se dirige o cómo le habla la madre de ella). Vínculo es la relación entre la niña y su acompañante, por ej. Cómo le habla.
- Indagar a cerca de los nombres que usan en la casa para referirse a los genitales.

Una buena anamnesis requiere tiempo, paciencia e idoneidad.

Además de lo referido al síntoma que es moti-

vo de consulta, debe incluir:
las circunstancias:

- físicas en que se presentó el problema (síntomas concomitantes o agregados)
- psíquicas (cambios de conducta)
- familiares (divorcios-fallecimientos)
- sociales (mudanzas, migraciones, con quién comparte la mayor parte del día).

Conviene indagar también:

- Si hubo consultas o tratamientos previos
- Qué le preocupa a la madre
- Qué le preocupa a la niña.

Premisas para realizar el examen físico

- Debe ser claramente explicado
- No debe limitarse al examen genital
- Debe comprender la inspección de todo el cuerpo
- Debe incluir la evaluación el crecimiento y desarrollo
- Debe incluir la palpación abdominal

Es aconsejable contar con un espejo: permite que la niña vea lo que se hace y se aprovecha para explicarle cada una de las estructuras.

En qué posiciones realizar el examen genital de la recién nacida y de la niña:

Posición en decúbito dorsal: con flexión y abducción de muslos.



Posición genupectoral o lateral: para la observación de la región anal.



Hasta los 3 ó 4 años, se la puede revisar sobre la falda de la madre y que ésta realice la maniobra de abducción de muslos y separación de los labios.



También puede ser examinada en la camilla, con la colaboración de la mamá o de ella misma, si es más grande.

No olvidar la importancia del espejo. El espejo sirve para que la niña pueda observar lo que se le está haciendo

¿Qué podemos observar en la recién nacida?

Lesiones dermatológicas de la vulva
Hemorragia o leucorrea



Tamaño y características del himen
Permeabilidad del orificio himeneal
Características de los orificios anal y uretral
Signos de violencia o traumatismo

¿Qué se puede ver en la niña?

Lo mismo que en la recién nacida, además:

Coalescencia de labios (*foto sinequia*)

Signos de infección vulvovaginal

Signos de estrogenización

Telarca: Aparición de desarrollo mamario que se manifiesta como botón mamario, detectable como pequeña masa retroareolar, a veces unilateral, a veces con aumento de sensibilidad.

Pubarca: Aparición del vello púbico es expresión de la adrenarca y responde a la acción androgénica.

Axilarca: Aparición de vello axilar.

Variaciones normales de la configuración vulvar (variaciones en la longitud de los labios, labios aliformes, etc.)



Vaginoscopio

¿Qué estudios complementarios podemos pedir a esta edad?

- Cultivos de secreciones (con tipificación de gérmenes y eventual antibiograma)
- Serología para ITS, en caso de sospecha de ASI (abuso sexual infantil)
- Vaginoscopia (método de diagnóstico por medio de un instrumento que permite visualizar la vagina y el cuello uterino)
- Valoración de la edad ósea por medio de radiología (Le sugerimos que repase la clase de Crecimiento y Desarrollo, donde encontrará estos temas)

- Dosajes hormonales a veces es necesario valorar los niveles de gonadotrofinas o esteroides sexuales y/andrenales.
- Ecografía abdominal y ginecológica: la ecografía ha desplazado en la actualidad la necesidad de realizar un tacto rectal en las niñas.
- Resonancia nuclear magnética (actualmente ha desplazado a la tomografía computarizada, muy útil cuando sospechamos malformaciones o tumores)
- Otros estudios que sean pertinentes.

¿Por qué viene a la consulta una púber?

- Porque comenzaron los cambios físicos y la madre quiere que la controlen
- Porque aparecen síntomas que la molestan o perturban
- Porque la madre quiere que establezca una relación con quien la va a atender en las siguientes etapas de la vida.
- Porque presenta algún problema relacionado con el aparato reproductivo.

¿Cómo manejar la entrevista?

La entrevista requiere ser manejada con:

Habilidad (si la madre es la que habla hay que destacar la situación sin desautorizarla) para poder investigar (desempeño escolar, vida de relación, hábitos alimentarios, amigos, salidas, cronología de los cambios puberales y cómo los está viviendo, vacunación, vínculo entre la madre y la hija); explorando el verdadero motivo de la consulta y ofreciendo un espacio a solas, expresando que luego se incorporará la madre.

Y por sobre todas las cosas explicando con un lenguaje comprensible los cambios puberales y sus variables, utilizando en lo posible material gráfico, cuando la consulta está relacionada con esta etapa.

En caso de existir alguna patología conviene generar un clima de tranquilidad destacando los datos positivos y siendo cauto antes de dar un diagnóstico o pronóstico si no se está muy seguro de lo que se dice.

El examen físico debe ser:

Completo: peso, talla, tensión arterial, grados de Tanner (Con respecto de éstos, también le sugerimos que repase la clase de Crecimiento y Desarrollo) postura, columna y palpación abdominal.

Respetando el pudor: que en esta etapa está

exacerbado y por lo tanto debe tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo el examen.

Resaltando todo lo que está normal.

Examen genital:

No es necesario practicarlo en la primera consulta a menos que sea el motivo de consulta.

Se puede ofrecer hacerlo para mostrarle las partes que componen sus genitales externos. Es una buena oportunidad aprovechar la consulta mostrarle a la jovencita las características normales de su aparato genital utilizando para ella el espejo y algún objeto para señalar las diferentes estructuras, explicando su función y utilizando los nombres correctos.

No olvidarse de valorar:

Los grados de Tanner

Signos de infección

Permeabilidad del himen

Malformaciones

No olvidar las mamas

Estudios complementarios:

Se solicitarán sólo aquellos que surjan de un diagnóstico presuntivo

Edad ósea y ecografía ginecológica (para variantes de la pubertad y para confirmar normalidad).

¿Por qué llega a la consulta una adolescente?

- Alteraciones del ciclo en la adolescencia temprana
- En la adolescencia media y tardía la mayoría de las consultas tienen que ver con la sexualidad
- Puede concurrir acompañada, o no.
- Algunas veces viene derivada desde un juzgado, en general en relación a ASI o maltrato.

En la entrevista es aconsejable poner el énfasis en:

Adaptarla al período de la adolescencia en que se encuentra

Ofrecer espacio para la consulta individual

Es importante explicar el marco ético y legal.

Tratar de generar un clima agradable

Recordar que la adolescente es la protagonista

Saber posponer lo importante respetando la demanda

Poner énfasis en la salud con una mirada preventiva

De lo que la adolescente sienta en este primer

encuentro o acercamiento dependerá que vuelva permitiendo de este modo su seguimiento.

Es de mucha utilidad enmarcar la consulta desde un enfoque de riesgo.

No perder de vista la integralidad (vida de relación, parejas, actividades, alimentación, actividad física, hábitos de higiene, actitudes poco saludables, proyecto de vida, relación familiar)

Prolija anamnesis: indagar sobre calidad de información sobre sexualidad.

Examen físico en la adolescente:

Completo: peso, talla, tensión arterial, grado de Tanner, postura, columna, palpación abdominal y mamas.

Respeto por su pudor, resguardando la privacidad.

Examen ginecológico:

Tenemos la posibilidad de transitar dos escenarios:

Si la adolescente no ha iniciado relaciones:

a-Posponer el examen a menos que sea el motivo de consulta.

b-En caso de que sea necesario practicarlo, evaluar cuidadosamente cada maniobra y valorar la posibilidad de obtener información por otros métodos complementarios (ha caído en desuso el tacto rectal ya que la información proveniente de la ecografía o resonancia es fidedigna).

Si ya tiene relaciones, también podemos estar ante dos situaciones:

Que nunca hayan sido revisadas: en ese caso debemos explicarles el objetivo de la revisión, cuánto puede tardar y los beneficios de realizarla. (ver foto)

Que ya hayan sido revisadas: en ese caso procederemos a realizar vulvoscopy, colposcopy, toma de muestra para Papanicolaou, tacto vaginal.



A modo de resumen

La consulta en todas las edades es un medio de comunicación invaluable.

Debe ser realizada en forma idónea por un adulto responsable que ofrezca respuestas válidas, sin olvidar la integralidad de la misma.

Debe permitir que el adolescente vuelva

Es importante lograr un diagnóstico aproximado de situación para no pedir estudios complementarios innecesarios.

Poder distinguir entre la demanda real del paciente y del acompañante.

Diferenciar la emergencia de lo importante

Dejar creada la necesidad de continuidad.

Al final de la consulta se debe informar:

Los hallazgos en forma comprensible

Resaltando los hechos positivos y la normalidad,

La presunción diagnóstica

Y los estudios necesarios para completar el diagnóstico con las

Posibles terapéuticas.

Se agradece la colaboración en la galería de fotos de las siguientes Doctoras: Beatriz Pereyra Pacheco, Ana Coll y Paula Califano.

Bibliografía

-

Herriot Emans SJ, Marc R. Laufer, Donald Peter Goldstein. Ginecología en pediatría y la adolescencia. Mc Graw Hill Interamericana, 2000

Méndez Ribas JM y colaboradores. Enfoque Actual de la adolescente por el ginecólogo. Editorial Azcune Hnos, 1993

Riopedre P. Primera consulta ginecológica: ¿cuándo es el mejor momento?

Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. Manual de Ginecología Infanto Juvenil. 2º Edición. Editorial Azcune Hnos, 2003

***Dr. Pablo Gabriel Dei-Cas**

Jefe del Servicio de Pediatría del HIGA Presidente Perón de Avellaneda. Instructor de Residentes.

Docente Adscripto UBA.

EL ENMARAÑADO DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS PSÍQUICOS EN PEDIATRÍA



DR. FERNANDO ALONSO*

Introducción

Enmarcar los problemas psíquicos de niños y adolescentes en un sistema diagnóstico específico es algo que se ha cuestionado y se cuestiona en forma permanente. Durante muchos años, expertos de diferentes disciplinas, apoyados en campos teóricos disímiles, han intentado localizar la enfermedad mental construyendo operaciones diagnósticas muy variadas y creando múltiples hipótesis sobre su origen.

Dentro de la gran variedad de formas de evaluar el malestar psíquico en pediatría, vamos a detenernos en dos: la psiquiatría y el psicoanálisis. Estas dos orientaciones responden a problemáticas clínicas diferentes. Por lo tanto, la mirada sobre el paciente no será la misma ni mucho menos el modo de intervención.

Elegir una u otra o pretender una mixtura de la psiquiatría con el psicoanálisis no es la meta de este trabajo. Lo que intentaremos es analizar ambos métodos con el objetivo de conocer tanto sus fundamentos como sus limitaciones y así proveer al médico que trabaja con niños y adolescentes de herramientas para realizar su práctica en el campo de la clínica.

Diagnóstico. Su valor

La palabra diagnóstico viene de diagnosis. Diagnosis significa capacidad de discernir, distinguir, reconocer; esto implica la decisión de un parecer, un dictamen, es decir, un juicio. En su propia etimología, diagnóstico es juicio.

Ante un paciente que refiere un malestar, el

diagnóstico es una operación fundamental en la práctica médica. Se trata por una parte de un procedimiento con el que se intenta, con la recolección de datos, localizar un síndrome, un proceso patológico, una enfermedad hasta lograr hacer un juicio, es decir, discernir en forma razonada la causa del padecimiento. Por otra parte, como sucede en los controles periódicos en pediatría, es un método para verificar y certificar el estado de salud de una persona.

Si bien los problemas psíquicos son más complejos de categorizar para los médicos psiquiatras, así como para quienes se posicionan desde el psicoanálisis, el diagnóstico es fundamental, ya que con él podemos orientar la estrategia y la dirección del abordaje terapéutico.

Debemos recordar que en pediatría esta operación es mucho más complicada. En primer lugar, porque el que demanda la consulta, en general, no es el niño sino sus padres, que están preocupados o ya no saben más qué hacer con su hijo. En segundo lugar, muchas veces el paciente es derivado por alguien (escuela, gabinete, justicia, etc.) y el niño es traído a la consulta por adultos, que en numerosas oportunidades ni siquiera registran el problema.

Psiquiatría y psicoanálisis, dos modos diferentes

Un diagnóstico preciso es fundamental para el psiquiatra al igual que para el psicoanalista. Esto no lo podemos soslayar, ya que permite orientarse y decidir la dirección terapéutica específica, aunque sabemos que la estrategia y los

objetivos de cada disciplina son diferentes.

Si bien se trata de una especialidad médica, hacer diagnóstico en psiquiatría no es lo mismo que en medicina en general. Esto se debe a que los fenómenos mentales no se ajustan a una regla biológica donde, como bien saben los clínicos, determinados síntomas orientan al profesional respecto del órgano afectado y guían la decisión del remedio o práctica adecuada para resolver el problema.

El padecimiento psíquico compromete algo que está más allá de lo orgánico y, además, se escapa de las reglas normativizadas. En cada persona, sus vivencias, su historia, su autobiografía, su manera de darle sentido a lo que le pasa son únicas y no encajan nunca con un saber preestablecido. El niño, asimismo, está enmarcado en la dinámica de su grupo familiar y especialmente influenciado por las funciones parentales de transmisión y regulación.

Hacer diagnóstico equivale a la construcción de una clase (Tendlarz, 2009). Una clase es un universal en el que entran las particularidades, las subjetividades. Por un lado, tenemos las clases y, por otro, a cada niño que entra dentro de cada clase. La clínica psiquiátrica usa la lógica de clases, iguala y separa de a grupos (junta a los pacientes autistas, a los hiperkinéticos, a los disociales, etc.). En cambio, el psicoanálisis, aplicando la lógica de los conjuntos, no puede agrupar pacientes, dado que considera a cada niño o adolescente un ser único, un conjunto de singularidades irrepetible, cada persona es un mundo.

El diagnóstico de los problemas psíquicos debe combinar lo universal con lo original, lo general con lo singular de cada paciente, siempre en un marco de formalización y conceptualización bien definido.

En general, la psiquiatría actual, alejándose de la psiquiatría clásica, se restringe a la exploración del paciente con métodos tecnológicos y al uso de medicamentos para acallar los síntomas, haciendo hincapié en lo generalizado y normativizado, catalogando a los niños y adolescentes dentro de las clasificaciones universales disponibles, dejando de lado la condición de sujeto y sus particularidades individuales. También vemos analistas que, a pesar de que trabajan sobre la subjetividad del niño, pretenden interpretaciones eternas. Así postergan la definición diagnóstica durante años, si es que en algún

momento la realizan.

En la búsqueda de ampliar la mirada y multiplicar los modos de comprender al niño o adolescente que sufre, nos proponemos analizar ambos paradigmas. Está claro que la psiquiatría y el psicoanálisis son dos disciplinas distintas, aun cuando una y otra, desde su propio basamento teórico, buscan intervenir sobre el malestar psíquico. Intentaremos explorar un territorio común sin dejar de reconocer sus diferencias, con el fin utilizar ambos métodos en la práctica clínica y ampliar nuestra comprensión sobre el paciente.

Psiquiatría. Recorrido histórico

LA ALIENACIÓN MENTAL: La psiquiatría nace con Philippe Pinel a fines del siglo XVIII, cuando los “locos” dejan de ser considerados delincuentes para entrar en el ámbito de incumbencia médica. La alienación mental es concebida, en aquel entonces, como una condición independiente, opuesta a las otras enfermedades médicas, con manifestaciones propias que van desde la manía hasta la melancolía, pasando por la demencia y la idiocia. Considerada como una enfermedad única, la alienación mental se afronta siempre de la misma manera: tratamiento moral (trato humanitario para los pacientes mentales, con la abolición del maltrato y las coerciones) y aislamiento social.

LAS ENFERMEDADES MENTALES: A mediados del siglo XIX, el psiquiatra francés Jean Pierre Falret plantea que, lejos de tratarse de una sola enfermedad (la alienación mental), la patología en el campo de lo psíquico se compone de una serie de especies mórbidas, las enfermedades mentales, y pone el acento en la observación atenta y descripción de síntomas para poder realizar un diagnóstico diferencial preciso, diseñar el tratamiento y establecer el pronóstico. Esto crea, en ese momento, un escenario muy adecuado para el desarrollo marcado de la semiología y la construcción de grandes nosografías.

LAS GRANDES ESTRUCTURAS: Posteriormente, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza un período donde se intentan buscar explicaciones orientadas a los síntomas y sus mecanismos de producción. Es el tiempo de las grandes estructuras en el que priman las nociones de neurosis y psicosis con la influencia

del psicoanálisis (Sigmund Freud, 1856-1939) en el pensamiento médico. En esa época, Melanie Klein (1882-1960) y Ana Freud (1895-1962) realizan grandes aportes en el campo de la psicopatología infantil.

TIEMPOS DEL DSM: A fines del siglo XX, con la prevalencia de las neurociencias y la psicofarmacología, una psiquiatría tecnológica y biológica plantea la redefinición de lo normal y lo patológico. Diluye las categorías de neurosis y psicosis en los nuevos manuales diagnósticos como el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM) publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association - APA) y en la Clasificación internacional de enfermedades (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - CIE) de la Organización Mundial de la Salud.

En la década del 80, época en que se publica la versión del DSM III, manual que es adoptado como guía diagnóstica por grupos de trabajo y profesionales de muchos países del mundo, se afianza el retorno a formas clínicas concebidas como “congeladas” (categorías y trastornos) alrededor de la presencia-ausencia de un conjunto de signos (criterios clínicos) preestablecidos.

En la actualidad, si bien hay excepciones, muchos psiquiatras han abandonado el camino que siguieron sus maestros clásicos para hacer eje en la investigación científica pragmática, cada vez más orientada a la cuestión biológica y tecnológica (neurotransmisores, imágenes cerebrales, mapas genéticos). Apoyada en un paradigma positivista, busca la objetividad, desvalorizando la subjetividad del paciente al cual se lo escucha poco, así como reemplazando el saber, la experiencia y el ojo clínico del médico con escalas, guías y protocolos preestablecidos.

PSIQUIATRÍA CLÁSICA VS. PSIQUIATRÍA ACTUAL: Es importante diferenciar la psiquiatría clásica de la psiquiatría actual. La primera, que podemos ubicar entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se destacó por el despliegue de una exquisita semiología y la construcción de grandes nosologías que sirvieron de base ordenadora, tanto a la psiquiatría contemporánea como al psicoanálisis (recordemos que el origen del psicoanálisis, en parte, se forja en la psiquiatría clásica, más allá de que luego generara un campo y prácticas propias y específicas).

La segunda, la psiquiatría actual, nace a mediados del siglo XX, los psiquiatras comienzan a enfocarse más en los procesos neuroquímicos, coincidiendo con la mayor oferta de medicamentos que producen los laboratorios, aplicando una práctica mecanicista (todo se reduce a trastornos tratables con medicación).

Este camino que tomó la psiquiatría, acompañada por la psicología del comportamiento, remeda de alguna forma los tiempos del siglo XIX en que se hablaba de las enfermedades mentales. Esta dirección que tomó la especialidad se fue profundizando con la creación de psicofármacos de segunda generación y los progresos en la técnica (estadísticas, cifras, escalas y test) y tecnología (diagnóstico por imágenes, genética, neurotransmisores), así como las periódicas actualizaciones los DSM (DSM I, 1952; DSM II, 1968; DSM III, 1975; DSM III-R, 1987; DSM IV, 1994, DSM IV-TR, 2000; DSM 5, 2013) que promovieron cada vez más la idea de trastorno mental como una enfermedad.

De esta forma, se fue afianzando la hipótesis que sostiene un origen biológico del padecimiento mental, el uso de protocolos y guías universales para hacer un diagnóstico casi “automático” y un tratamiento basado en fármacos, en terapias educativas y de rehabilitación.

La mirada y la escucha

Michel Foucault, psicólogo y filósofo francés, en su libro *El nacimiento de la clínica* (1963) hace una arqueología de la clínica médica destacando el valor de la mirada como instrumento de conocimiento. Este autor pone en primer plano las formas de ver y decir del médico llamándolas “clínica de la mirada” por la observación detallada y la prolija descripción de fenómenos clínicos, además de la posterior clasificación con criterios taxonómicos precisos donde se logra un ordenamiento de cuadros clínicos con criterios definidos.

La psiquiatría clásica fenomenológica, sin duda, enriqueció las minuciosas descripciones de la semiología que dieron pie a las grandes clasificaciones nosológicas. La semiología, para la medicina, es la ciencia que estudia los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico.

El neurólogo austríaco Sigmund Freud (1856-1939), y luego el psiquiatra francés Jacques Lacan (1901-1981), fueron médicos con una visión diferente a la clásica, de tal modo que pudieron trastocar, alterar, transformar la noción misma de la semiología como simple ciencia de los signos, ocupándose también del significante, punto de partida para localizar el significado. Es decir, elaboraron una teoría más sofisticada de la subjetividad humana, además de una técnica terapéutica innovadora. Estos autores partieron de la clínica psiquiátrica de su época y le dieron un nuevo esclarecimiento, provocando un movimiento tal que terminaron alterando y reconstruyendo la clínica en la que se habían formado.

Freud y Lacan, dos médicos que con el psicoanálisis se dedicaron a explorar el alma, el sentido íntimo de la psiquis, no eliminaron la psiquiatría descriptiva, pero de alguna manera podríamos decir que la subvirtieron. Si la clínica psiquiátrica es la clínica de la mirada, podríamos pensar, siguiendo a Bercherie (1986), la clínica psicoanalítica como la clínica de la escucha.

Según la psicoanalista y docente de la UBA Tomasa San Miguel (2013), la limitación de la clínica psiquiátrica está en concebir la mirada médica como una traducción fidedigna de lo que pasa con el paciente, como si el lenguaje con que se transmite lo observado no tuviera fisuras.

El psiquiatra y el psicoanalista ven los comportamientos y oyen lo que los pacientes dicen, pero hay una diferencia: el psicoanálisis no se deslumbra por lo imaginario (tal como lo hacen las ilusiones ópticas), corre la cortina de la ilusión y se sumerge en lo no evidente de lo simbólico. Para la psiquiatría el saber está en lo real, construye su verdad con lo que se ve y con los dichos del paciente, considerando que los síntomas hablan y transmiten un saber literal. Todos los fenómenos observables y todo lo que se dice sobre el niño, o lo que él mismo menciona, permitirían comprender lo que sucede.

La mirada, esa dimensión sobre la que se sostiene la psiquiatría clásica, revela aquí su alcance y también su límite. Esta información, obtenida en las consultas con los padres, acompañantes y con el mismo paciente, no tiene más que un sentido; de este modo, el psiquiatra asume lo que mira y lo que oye como un todo, en forma literal, sin agujeros, sin secretos.

Aunque al principio Freud buscaba relacionar los dichos de sus pacientes con los hechos rea-

les, desde muy temprano en su práctica hizo un cambio rotundo: le dio valor a lo que el paciente le decía, más allá de poder corroborarlo en lo real. En efecto, no se quedaba solo con lo enunciado, los dichos no le eran suficientes. La palabra no alcanzaba por sí sola, era fundamental cuestionar la posición que tomaba el que hablaba con relación a sus propios dichos (Miller, JA, 1997).

Un niño puede decir algo sin creer completamente lo que dice, otro puede decir que quiere algo y desear exactamente lo contrario, y ni hablar de los lapsus, los olvidos y los secretos familiares. La novedad que trae el psicoanálisis es interpretar más allá de lo dicho, explorar detrás de lo enunciado.

Un médico que se dispone a escuchar a un niño desde esta perspectiva debe estar atento a los enunciados, a sus asociaciones, a la repetición del discurso de sus padres (diferenciándolo de su propia verdad), a la modulación de sus dichos, a lo que se niega u omite. De esta manera, podrá hacer una lectura entre líneas de sus palabras intentando realizar de este modo una fina exploración semiológica de lo más íntimo y singular de ese niño: su subjetividad.

Lo que está a la vista... y el resto

El gran hallazgo del psicoanálisis es que no somos transparentes, que estamos divididos, que el inconsciente manda sobre la conciencia, que la razón va por un lado cuando la pulsión va por otro y que el lenguaje tiene agujeros que provocan malentendidos, enrareciendo su función de comunicación. Esto hace la diferencia entre psicoanálisis y psiquiatría.

La psiquiatría detecta lo que le pasa al paciente con la mirada y con los dichos, busca signos y síntomas en cada persona que explora para así encontrar similitudes con algún síndrome ya descrito anteriormente que se le asemeje. Se apareja a otros pacientes ya vistos o diagnosticados, se los iguala y agrupa para finalmente clasificarlos en grandes nomenclaturas que se actualizan periódicamente. En este proceso, se diferencia lo anormal de todo lo que se considera normal en forma preestablecida. Y si el caso es clasificable luego de evaluarlo, estudiarlo, discutirlo, tal como en la mitología griega el posadero Procusto ajustaba a cada huésped a su lecho de piedra, cortando los pies a los altos,

estirando a los bajos (Grimal, 1981), se crea un constructo a medida, se estrena un síndrome nuevo acorde a los síntomas que no se han podido encasillar o se lo ubica como trastorno no especificado, una verdadera bolsa de gatos.

No es lo mismo individuo que sujeto. El diagnóstico psiquiátrico apunta a la objetividad del individuo, soslayando la singularidad (el sujeto) imposible de comparar. La psiquiatría prefiere quedarse solo con el individuo, alguien que pertenece a una especie, la de los seres humanos, y se lo iguala a sus pares en muchos aspectos. Sin duda lo podemos normativizar, pero el individuo, el viviente humano, cuando deviene sujeto, cuando tiene nombre, un deseo no anónimo, gustos personales y un modo de ser propio y singular, una historia, se separa para siempre de sus iguales.

Esta singularidad, este resto inclasificable, todo lo que de cada paciente el médico no puede acomodar en ninguna categorización es lo que la psiquiatría trata de anular y, si no puede lograrlo, lo disimula en categorías imprecisas como trastornos no especificados.

El síntoma y la mirada del psicoanálisis

Si bien desde la psiquiatría hay un intento permanente de delimitar en forma precisa las nociones de salud y enfermedad, no es viable definir los límites entre la locura y la cordura con absoluta claridad.

El concepto de “normalidad” parte de un consenso general de lo que sería normal, pero este modo de definición funciona para hacer las normas de tránsito o instrucciones de cómo se debe envasar un litro de leche. Tan es así que la definición precisa de este concepto en salud mental es imposible de alcanzar y muchas veces provoca efectos indeseables tales como la segregación o la estigmatización. En la actualidad, de la mano de la psiquiatría y la psicología de la conducta, existe un ideal de cómo tienen que ser los comportamientos esperados y por lo tanto cuando esta norma no se cumple estaríamos ante un trastorno o un defecto.

Podríamos decir que, por un lado, la psiquiatría se encarga de la normalidad y la anormalidad, de lo visible. Por otro lado, el psicoanálisis trabaja sobre el residuo, lo que se esconde bajo la alfombra, lo que resta de esta operación entre normalidad y anormalidad que nunca logra aco-

modarse del todo.

Para el psiquiatra, como en medicina general, el síntoma es algo que no debe estar. Por ello, si aparece, es una señal de que algo no funciona. Para el psicoanálisis el concepto de síntoma es muy diferente, ya que, desde esta posición teórica, siempre habrá síntoma. Esto se debe a que el lazo social, inherente al ser humano, conlleva un malestar que no deja de hacerse presente a lo largo de toda la vida. Que la felicidad absoluta sea imposible de alcanzar ya lo expresó Freud en su texto *El malestar en la cultura* (1830).

El ser humano, a diferencia del resto de los integrantes del reino animal, nace imperfecto, sin un bagaje instintivo que lo oriente, inerme para arreglárselas por su cuenta. Siempre necesita de otro que lo auxilie (primero será su madre o quien la represente y luego habrá otros) para poder sobrevivir y esta condición imprescindible lo obliga a depender del lazo social.

No obstante, relacionarse con los demás tiene un alto costo: el ser humano tendrá que renunciar a la pretensión de alcanzar satisfacción plena e individual y asumir que los demás, con los que debe relacionarse, tienen intereses diferentes a los suyos. Esto lo enfrenta a una situación irrefutable: que todo no se puede.

Esta resignación del goce sin límites es la razón por la que nunca el bienestar y la armonía serán totales (no existe la media naranja). El ser hablante está condenado a la búsqueda de la felicidad en forma permanente y la manera de expresar esto es con sus síntomas.

El “cachorro humano” nace inerme y lo que lo sostiene es la red imaginaria y simbólica que le ofrecen quienes lo reciben, en general sus padres. Pero nada le será fácil, el recién nacido tendrá que hacer algo para engancharse a la cultura, a las palabras, al entramado social que se le ofrece. Además de renunciar al goce sin límites, debe buscar un recurso para poder enlazar el bagaje biológico “fallado” que trae consigo con las imágenes y palabras que los padres le ofrecen. A ese invento, que funcionará como gancho o enlace, podríamos nombrarlo síntoma-solución.

El síntoma-solución es la forma de ser, la personalidad, la “chifladura propia” que cada niño crea en forma original. Se trata de un modo particular que inventa para arreglárselas con el mundo real, atestado de contingencias que no comprende y nunca comprenderá del todo,

y lidiar con una vida de relación que siempre lo enfrentará a desajustes en la armonía algunas veces alcanzada.

Estar vivo no es lo mismo que existir y para existir el niño funda su deseo no anónimo, su modo de lograr satisfacción siempre singular, su manera de hacer lazo con los demás (una niña es la histriónica y disfruta de bailar y actuar frente a sus pares; otro es el atleta y deportista que se destaca por su destreza; un tercero, el forzado y bravucón que defiende al grupo o lo amedrenta; otra joven es la estudiosa, abanderada, el orgullo de la familia y la inteligente del grupo, etc.).

Pero esta herramienta que el niño genera, el síntoma-solución, no es perfecta y el “nudo” con el que se enlaza a lo social que parece tan firme, tal como el de una zapatilla, de repente, se puede desatar. Es entonces cuando aparece el síntoma que produce malestar. Este síntoma está más cercano al síntoma de la psiquiatría y podríamos llamarlo síntoma-problema (el niño deportista se pone agresivo en su juego con gran intolerancia a la frustración o el abanderado no deja de estudiar y pierde a su grupo de amigos, etc.).

El uso de diferentes paradigmas

Sin prejuzgar los modos de ver los problemas psíquicos de un niño analizados, vamos a tratar de delimitar el uso que podemos darle a cada una de estas teorías en la clínica pediátrica.

LA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: La clínica de la mirada, aquella clínica fenomenológica que habitualmente se usa en psiquiatría, es muy importante para localizar lo que le pasa al paciente. Y, si bien tiene cierta limitación para profundizar en la raíz del problema, es fundamental y necesaria a la hora de decidir el uso de alguna medicación, si esta fuera necesaria.

Los medicamentos psicofarmacológicos no curan un problema psiquiátrico, no remedian una enfermedad, solo eliminan el síntoma sin importar su causa. Son medicamentos sintomáticos, es decir, solo calman o alivian los síntomas en aquellos padecimientos que se desconocen o que no tienen un tratamiento eficaz. Por ejemplo, si un niño presenta una crisis de agitación con alucinaciones, lo que está indicado, hasta encontrar el origen del fenómeno observable, es suministrarle un antipsicótico más allá de que se trate de una intoxicación por alucinógenos,

un lupus, un tumor, un accidente cerebrovascular o una psicosis descompensada.

El abordaje fenomenológico también resulta propicio cuando tenemos la necesidad de facilitar la comunicación entre profesionales de diferentes disciplinas al organizar un servicio, planificar estrategias interdisciplinarias y/o lograr un intercambio de ideas en los equipos de trabajo, así como el diseño para algunos estudios de investigación clínica de corte neurocientífico.

Asimismo, este paradigma, típico de la psiquiatría, es esencial en la gestión hospitalaria o de salud pública y en el funcionamiento burocrático de los servicios de salud. De igual modo, la justicia, el servicio social e incluso en educación, en muchas circunstancias utilizan el modelo psiquiátrico cuando se refieren al malestar psíquico de un niño o un adolescente.

El psiquiatra precisa una mirada fenomenológica fina y detallada, tanto para la evaluación y el seguimiento como para el control de los posibles efectos adversos de las drogas indicadas por él mismo. Pero es importante que tenga en cuenta que la verdad no es un plano blanco o negro, sino más bien tridimensional. En otras palabras, no se debe olvidar que bajo esta mirada solo se está viendo una cara de las muchas que tiene el padecimiento psíquico.

CLÍNICA PSICOANALÍTICA: Un paciente, además de ser un individuo miembro de una especie, un ser vivo con un organismo biológico y comportamientos medibles y comparables, es un sujeto con nombre propio que no tiene conductas instintivas, sino actos propios y originales que ha decidido realizar (consciente o inconscientemente). Es una persona con características singulares, es impar e incomparable, con una historia propia, un modo de dar sentido a sus vivencias, con un deseo particular, poseedor de una manera de gozar y sufrir totalmente subjetiva.

El psicoanálisis puede constituir un refugio propio de la clínica, tal como lo dice Miller (1987), y ser utilizado por psiquiatras como por otros médicos que en la consulta habitual todavía pretenden darle un lugar al sujeto y valoran la palabra de sus pacientes, haciendo oídos sordos al mandato actual de reducir la medicina a una práctica automática ejercida con protocolos que anulan la subjetividad del paciente, y también la del médico.

Además de conservar su mirada objetiva so-

bre el paciente, el médico, echando mano a las enseñanzas del psicoanálisis, podrá explorar lo más íntimo del síntoma de un niño o de un adolescente por el que le han consultado. De esta manera, el clínico no solo detectará lo que le pasa al paciente, sino que también podrá profundizar en el por qué le pasa lo que le pasa, logrando hacer diagnóstico de la posición que el niño toma ante los demás, su lugar en el mundo, su estructura psíquica, el sentido que tienen los fenómenos clínicos que observa en él y, paradójicamente, para qué está usando este síntoma ahora (ej.: ser aceptado en un grupo, poner distancia de lo angustiante que le resulta el encuentro sexual, no perder los privilegios de ser “nene de mamá”, etc.).

La clínica de la escucha, dándole un lugar a la palabra, permite dilucidar no solo el lugar que ocupa el niño en el entramado familiar y en lo social (síntoma-solución), sino también comprender y descifrar el enigma que conlleva el síntoma cuando provoca malestar (síntoma-problema). Así, permite dirigir el tratamiento hacia una modificación de todos aquellos síntomas (hiperactividad, anorexia, drogas, etc.) hasta ahora usados para bien o para mal y que en este momento le producen malestar.

La clínica nos enseña cada día que estos síntomas-problema, en determinado momento, para el niño no son un inconveniente y, aunque alteren el bienestar, también les da cierta satisfacción paradójica, le hacen cursar un tiempo de “luna de miel” con su síntoma (drogas para evadirse de lo real, agresividad para no renunciar a su satisfacción sin límites, anorexia para seguir siendo una niña, etc.), durante el que se sienten cómodos con él o le sacan provecho. Esto permite entender la repetición y recaída en conductas que van a contramano de lo esperable, y por qué el ser humano es tan propenso a tropezar dos o más veces con la misma piedra.

El síntoma, para el psicoanálisis es solo una envoltura, es una defensa ante la angustia, es un invento para enfrentarse al mundo real y siempre esconde una raíz que conviene explorar. Las formas que toman los síntomas no nos dicen nada. Estos varían mucho, por ello hoy vemos cuadros clínicos que hace décadas eran diferentes o menos frecuentes: varones con anorexia, niños hiper-cinéticos agresivos, jóvenes que se hacen marcas en el cuerpo para calmar su angustia, adicciones a pantallas electrónicas de

todo tipo, niños aislados que solo toleran la inmutabilidad y la soledad, etc.

Conclusiones

El síntoma psíquico se presenta como un fenómeno clínico que llama la atención y provoca malestar al niño o adolescente, así como a quienes lo rodean. La presentación sindrómica varía, pero la raíz es fija. Una joven anoréxica puede ser psicótica o sólo tratarse de uno más de los síntomas neuróticos frecuentes en la adolescencia. Un mismo niño a lo largo de su vida puede presentar síntomas variados: opositorista a los dos años, desatento a los seis, agresivo a los ocho, deprimido a los once, y todas podrían ser manifestaciones de una problemática familiar con padres abusadores o, por el contrario, podría denotar una relación simbiótica con su madre sobreprotectora, entre múltiples posibilidades.

No hay evidencias de causas genéticas o biológicas, pero no podemos desconocer ni lo que concierne a lo orgánico ni a la subjetividad. Hemos visto una joven de 19 años en quien se sospechaba bulimia por sus vómitos, atracones y descenso de peso que finalmente era diabética; una nena de 10 años con supuesta anorexia que era celíaca; un joven de 14 años con alucinaciones en quien se diagnosticó un lupus; un niño de 10 años con conductas extravagantes y disruptivas en el que finalmente se confirmó que padecía una epilepsia del lóbulo temporal. También observamos a diario la “neurologización” del sufrimiento psíquico, que provoca estigmatización, medicalización exagerada, pero fundamentalmente limita y posterga el encuentro con la causa de sus síntomas.

Cuando se trata “un cerebro” sin tener en cuenta al sujeto, rotulándolo y medicalizándolo, se anula la posibilidad de que el niño se interese por su síntoma, trate de entenderlo y se haga cargo de lo que hace o lo que dice (Pedro viene a consulta por su mala conducta en la escuela y cuando le pregunto: “¿Por qué se te ocurrió romper todos los vidrios de tu escuela?”, el niño me contesta muy tranquilo: “Es que soy bipolar”). Cerrado el diálogo y la posibilidad de pensar más allá de los hechos).

En otras circunstancias, hay casos que no se pueden abordar por la palabra, por lo menos en un principio, o son reticentes a un análisis:

un niño o adolescente con síntomas agudos muy graves (ataques de pánico, crisis de agitación autista) o que lo ponen en peligro tanto a él como a terceros (intento de suicidio, impulsividad) o son tan severos que no permiten la intervención por la palabra (mutismo psicótico). En estos casos, el criterioso uso de estrategias psiquiátricas como la psicoeducación o indicaciones precisas, la medicación psicotrópica y, en situaciones extremas, la internación, pueden ser imprescindibles.

Interrogantes

Luego de transitar por estas reflexiones sobre el diagnóstico del padecimiento psíquico en niños y adolescentes, se abren nuevos caminos y surgen muchos enigmas.

No alcanza con obtener títulos y lograr experiencia si no podemos localizar la demanda real que se pone en juego en la consulta de una familia con su hijo. “Percibir la necesidad de cambiar componentes tan esenciales como las formas de interacción en las relaciones interindividuales expresa el desafío de construir una nueva experiencia médica”, dice Schraiber (2019).

¿Será necesario que los que trabajamos con niños inventemos al médico que somos cada vez? ¿Hay más de una manera de evaluar al niño para poder comprender su malestar? ¿Es posible escuchar a un niño asumiendo que tiene una verdad para contarnos aquello que nosotros ignoramos? ¿Cuándo y cómo debemos usar un diagnóstico taxonómico para planificar la dirección de un abordaje terapéutico y cuándo conviene evitarlo para no rotular y medicalizar al niño o a la niña?

Reconocemos en este trabajo que la relación entre la psiquiatría y el psicoanálisis es compleja y difícil, pero no dejamos de plantearnos la posibilidad de hacer uso de ambos saberes como herramientas a la hora de tener que intervenir en la vida de un niño o un adolescente.

No cabe duda de que hay mucho para pensar y debatir respecto a qué hacer ante un niño o adolescente con sufrimiento psíquico, una familia preocupada por las dificultades que le plantea su hijo, una institución que reclama que nuestro paciente se ajuste a sus reglas.

¿Por qué motivo nos traen a consulta a este niño? ¿Es la demanda de los adultos la misma que la del niño? ¿Qué hay detrás del síntoma

que generó la consulta? ¿Se trata de una enfermedad biológica que se camufla con fenómenos mentales o los síntomas del paciente son solo una mascarada de un padecimiento psíquico? Nos preguntamos cómo afrontar la búsqueda de precisar un diagnóstico entendiendo que no hay una única verdad y que es imposible alcanzarla del todo.

¿Será viable arrimarnos a lo real de estos enigmas abriendo caminos, mirando desde diferentes ángulos, reconociendo otros saberes, asumiendo que nuestro conocimiento es parcial y limitado? ¿Es posible comprender que, en el ser humano, más allá de lo racional se esconde un saber?

Las respuestas a estos interrogantes pueden ser muchas, nosotros ensayamos una idea. Nuestra propuesta es sostener una ética de trabajo que conserve la especificidad teórica de cada especialidad, tanto de la psiquiatría como la del psicoanálisis, sin perder la pericia de un oficio de tal forma que el uso de ambas posiciones teóricas logre que un niño o adolescente se sienta mejor y consiga hacer un lazo armónico con los demás. Es decir, ante un niño, una niña o adolescente con padecimiento psíquico, consideramos legítimo echar mano de diferentes enseñanzas en búsqueda de aliviar el sufrimiento, curar lo que se pueda curar y acompañar al incurable.

Bibliografía

- Azubel, A. (2001) *Medicina y psicoanálisis. Evolución del concepto de neurosis en el campo médico*. Rosario, Santa fe, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
- Bassols, M. (2008) Conferencia realizada en el 41 Congreso de filósofos jóvenes sobre Filosofía y Locura, Barcelona 14 de abril de 2004. *CliniCAPS*, agosto, Vol 2 N°5 Belo Horizonte, Brasil.
- Bercherie, P. (1986) *Fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico*. Argentina: Editorial Manantial.
- Berrios, G. (2011) *Hacia una nueva epistemología de la Psiquiatría*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Polemos.
- Freud, S. (1930) *Obras completas de Sigmund Freud, volumen 17: Ensayos CLIII-CLXV - El malestar en la cultura*. Traducción Ballesteros y Torres. (Págs. 3017-3067) Madrid, España: Editorial Biblioteca Nueva.
- Klykkylo, M. D. (2015) *Fundamentos de la práctica psiquiátrica en niños y adolescentes*. En el libro *Clínica de la Psiquiatría Infanto Juvenil*. (Págs. 1-150) Buenos Aires, Argentina: editorial Inter-Médica.
- Dumas, A. (2018) *Destino, estilo y singularidad. La dignidad del niño analizante*. (Págs. 23-28) Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.
- Grimal, Pierre (2010). *Diccionario de mitología griega y romana*. (Pág. 454) Barcelona: Ediciones Paidós. pp. XIII.
- Godoy, C. (2013) *La psicopatología: de la psiquiatría al psicoanálisis*. En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 117-136) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones.
- Kaplun, H. (2003) *Acerca de un decir*. *Virtualia, Revista digital de la*

EOL.

Lacan, J. (1988). "Conferencia de Ginebra sobre el síntoma". *Intervenciones y textos*. Argentina: Editorial Manantial.

Laserre, A. (2015) *Una lectura de Nota sobre el niño*. Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.

Leibson, L. (2013) Actualidad de la psiquiatría clásica. En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 137-175) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones.

Leibson, L. (2013) La subversión de la psiquiatría y la formación del psicoanalista. En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 199-211) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones

Mazzuca, R. (2013) Ética psicopatología y psicoanálisis (Lo normal y lo patológico). En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 66-93) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones

Mazzuca, R. (2013) El diagnóstico en la psiquiatría y el psicoanálisis. En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 213-219) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones.

Miller, J.A. (1997) *Introducción a un discurso del método psicoanalítico*. Introducción al método psicoanalítico (Págs. 13-57) Barcelona, España: Editorial Paidós.

Najles, A. (1996) Los niños en la práctica cotidiana del psicoanálisis. En el libro *Una política de psicoanálisis con niños*, de la misma autora. (Págs. 45-52) La Paz, Bolivia: Plural Editores.

Owens, C. and Farrelly Quin, S. (2017) *Lacanian Psychoanalysis with Babies, Children, and Adolescents: Further Notes on the Child* 1st Edition. London, UK: Karnac Books Ltd.

San Miguel, T. (2013) La clínica psicoanalítica: un oficio. En el libro de Schejtman, F. *Psicopatología: clínica y ética*. (Págs. 92-106) Buenos Aires, Argentina: Grama ediciones.

Schraiber, L. B. (2019) El médico y la medicina: autonomía y vínculos de confianza en la práctica profesional del siglo XX. Universidad Nacional de Lanús. Colección Cuadernos del ISCo Serie Salud Colectiva. Remedios de Escalada, Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la UNLa.

Scheinkestel, A. (2007) Epistemología del diagnóstico y la clasificación. En el libro *Psiquiatría y Psicoanálisis del CICBA*. (Págs. 67-70) Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.

Stagnaro, J. C. (2007) Perspectiva crítica de las nosografías psiquiátricas contemporáneas. En el libro *Psiquiatría y Psicoanálisis del CICBA*. (Págs. 55-63) Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.

Tendlarz, S. (2009) Problemas clínicos contemporáneos. En el libro *Psicosis. Lo clásico y lo nuevo*. (Págs. 11-19) Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.

Tizio, H. (2011) Conferencia: La Función del Síntoma. Ciclo de Conferencias y Debates "Paradojas de la Salud Mental. Lacan y la Psiquiatría", organizado por ICF de Granada, España. Ver en <http://www.radiolacan.com/es/topic/214/4>

Vasen, J. (2011) *Una nueva epidemia de nombres impropios*. Buenos Aires, Argentina: editorial Noveduc.

Vasen, J. (2017) *¿Niños o Cerebros?* Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.

Wiener/Dulcan (2006) Evaluación y diagnóstico. En el libro *Tratado de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia*. (Págs. 71-216) Barcelona, España: Editorial Masson.

***Dr. Fernando Alonso**

Pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Psiquiatra Infanto Juvenil del Hospital Provincial de Rosario.

Responsable de la Concurrencia de Paidopsiquiatría del Hospital Provincial de Rosario. Profesor Titular en la Carrera de Posgrado de Especialización en Pediatría de la Universidad Nacional de Rosario.

DETECCIÓN PRIMARIA DE LAS CARDIOPATÍAS



DR. RICARDO GAMBOA*

A continuación daré algunas pautas básicas para poder diagnosticar una CC en la consulta ambulatoria.

¿Qué preguntar?

- ✓ El interrogatorio es fundamental. Hay antecedentes personales que pueden no estar relacionados con el motivo de consulta. Debemos preguntar sobre internaciones previas, síncope, intolerancia al ejercicio y mareos. El dolor de cabeza tipo migraña frecuente también es un dato relevante para sospechar CIA
- ✓ Los cuadros de bronquitis y asma tienen relación con CC con flujo pulmonar aumentado, por ejemplo CIA o PDA.
- ✓ Los antecedentes familiares también nos aportan datos claves. Cardiopatía en padres y tíos (“corazón grande”) y muerte súbita antes de los 40 años son claves para la sospecha diagnóstica de miocardiopatía, muchas veces familiar. Los italianos destacaron que el interrogatorio fue un arma importante para la detección de cardiopatías potenciales de muerte súbita en el deporte, en los exámenes precompetitivos para deportistas jóvenes.

¿Qué mirar?

- ✓ La observación e inspección comienzan en el mismo instante que el niño ingresa al consultorio junto a sus padres.
- ✓ Lo primero que tiene que llamar la atención es el hábito y las facies. El pediatra

tiene que estar atento y observar. Sus sentidos son fundamentales.

- ✓ Es obvio que el niño con síndrome de Down será detectado fácilmente. Pero a veces existen pacientes con fenotipo no tan evidente y que llegan sin diagnóstico con pocos meses de edad. El 50% de estos niños tienen CC y algunos sin soplo cardíaco.
- ✓ La facies tiene que llamar la atención.
- ✓ Hay caras típicas como la cara de duende del Síndrome de Williams, asociado a estenosis supra- aórtica y estenosis de ramas pulmonares.
- ✓ El aspecto general también. Aquellos pacientes altos y con dedos largos y flexibles obligan a sospechar Síndrome de Marfán. Pueden tener escoliosis y/o alteraciones de la visión, prácticamente completando la sospecha del síndrome y requiriendo la interconsulta con el cardiólogo. Estos pacientes pueden tener soplo de insuficiencia mitral o carecer de signos cardiológicos por completo. El posterior ecocardiograma puede detectar una dilatación de la raíz aórtica no sospechada de otra manera.
- ✓ La coloración de la piel y mucosas es muy importante. La cianosis manifiesta no merece comentario. Lo más difícil es la hipoxemia leve a moderada (saturación cercana a 85-88%) que puede no ser evidente, según la luz en el consultorio. Además depende de la concentración de hemoglobina. Actualmente cualquier pe-

diatra cuenta con un saturómetro transcutáneo, que puede ser muy útil en estos casos. También hay que mirar las uñas, sobre todo la del dedo gordo del pie (muy sensible a la hipoxemia crónica) con sus características uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor (hipocratismo digital). Son casos de cianosis de larga data pero que pueden pasar desapercibidos. La coloración rosada intensa de las mejillas puede hablar también de hipoxemia crónica.

- ✓ En el cuello pueden observarse elementos importantes. La presencia de latidos a nivel carotideo o supraesternal no es normal y deben hacer sospechar enfermedad valvular aórtica o coartación de aorta.
- ✓ La ingurgitación yugular es patológica, y junto a hepatomegalia y edemas de miembros inferiores son signos de insuficiencia cardíaca congestiva.
- ✓ Por último, el precordio es un elemento para prestar atención. Hay que mirar si está asimétrico, abombado en el lado izquierdo. Es útil observar al paciente “tangencialmente” desde los pies de la cama. Esto puede demostrar una deformación debida a cardiomegalia crónica. También es muy útil ver latidos anormales o si se observa moverse al corazón debajo del tórax, expresión de sobrecarga de volumen con cardiomegalia.

¿Qué tocar?

- ✓ Obviamente que en el precordio hay que tocar el choque de la punta, alrededor de las tetillas izquierda y derecha. Con esta simple maniobra ya comenzamos a sospechar situs inversus o dextrocardia.
- ✓ Hay que palpar el hueco supraesternal. Un frémito allí, prácticamente descarta cualquier “soplo funcional o inocente” y se puede sospechar firmemente estenosis aórtica moderada a severa.
- ✓ Lo principal que debe hacer el pediatra con sus dedos es palpar los pulsos femorales siempre. Con esta simple acción semiológica se hace el diagnóstico fácil de coartación de aorta. He tenido oportunidad de ver pacientes que habían sido examinados por otros médicos e inclusive,

le habían hecho ecocardiograma, sin llegar al diagnóstico, por haberle omitido palpar los pulsos femorales sin descubrir la ausencia de ellos. Inclusive he visto pacientes adultos recibiendo medicación para la “hipertensión arterial esencial” que tenían CoAo.

- ✓ Hay que palpar los pulsos a varios niveles, recordando que existen los pulsos axilares, humerales, radiales, carotideos, pedios, tibiales posteriores, etc.
- ✓ La palpación clara de pulsos interdigitales en las manos de un lactante prácticamente pone el sello al diagnóstico de conducto arterioso permeable (PDA).
- ✓ Obviamente que la palpación de una hepatomegalia sugiere el diagnóstico de congestión venosa sistémica por insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).
- ✓ Los edemas de miembros inferiores no son frecuentes en pediatría, pero su presencia es indicativa, en ausencia de otras causas evidentes (síndrome nefrótico) de ICC debida a miocarditis/miocardiopatía y debe disparar una obligada interconsulta con el cardiólogo pediatra. Muchas veces estos pacientes pueden no tener soplo cardíaco, siendo los edemas y la hepatomegalia los elementos semiológicos predominantes a los pies de la camilla en el consultorio.

Como vemos, hay varios pasos previos para sospechar y detectar signos y síntomas de una CC y todavía no hemos tomado el estetoscopio.

¿Qué escuchar?

- ✓ La auscultación es, sin dudas, la piedra angular para el diagnóstico de una CC.
- ✓ En el niño de primera infancia es más fácil auscultar pero cuando es pequeño el llanto lo torna más difícil. Hay que tener la paciencia suficiente para esperar la apnea y concentrarse en el corazón.
- ✓ Lo principal es intentar una auscultación “por disección”. Primero concentrarse en el primer ruido (R1) y luego en el segundo (R2). El R2 es la “llave” diagnóstica. No hablamos de que el pediatra va a hacer el diagnóstico exacto de la CC cuando no es especialista. Solo remarcamos que escuchando un R2 anormal el médico detecta

que el niño se trata de “una carta de otro mazo”.

El R2 normal está desdoblado variando con la respiración, siendo la separación más evidente de sus dos componentes durante la espiración (tac, tac, tac, trac, tac, tac, tac trac...). El R2 que no varía así es anormal.

Generalmente se acompaña de un soplo, como veremos más adelante. Esto permite hacer el diagnóstico de sospecha de cardiopatía y decide derivarlo al cardiólogo infantil. Daremos unos ejemplos:

Un R2 desdoblado fijo (tac, trac, tac trac...) en inspiración y espiración junto a un soplo sistólico eyectivo en segundo espacio intercostal izquierdo (foco pulmonar) hace pensar en CIA. Si es una niña con más razón. Este es el diagnóstico que habitualmente pasa desapercibido hasta la edad adulta.

Un R2 único y apagado con soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar y cianosis nos obliga a pensar en tetralogía de Fallot, aunque la cianosis no sea muy intensa (saturación por debajo de 90%)

Vayamos a los silencios. Ya algunos ejemplos dimos de dos CC con soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar.

La sístole es lo más fácil. Hay que hacer abstracción de los ruidos y concentrarse en la sístole (R1, sístole, R2).

Primero tenemos que aclarar que todo niño normal, sin CC alguna, tiene un soplo cardíaco en algún momento de su vida. Sobre todo cuando se presenta con fiebre y taquicardia.

Concepto número 1: todo niño normal tiene soplo.

Es cuestión de saber escucharlo, tener paciencia y destreza. Entonces hablamos de soplo funcional, inocente, o soplo normal. No hacemos la distinción en que si el niño tiene anemia el soplo es “funcional” y que si no la tiene es “inocente”. Todos son sinónimos y lo que se quiere remarcar es que el niño no tiene una cardiopatía.

Existen 5 tipos de soplos inocentes (SI): 4 sistólicos y uno sistodiastólico (continuo).

Sistólicos

1.- Vibratorio de Still

Este SI se escucha en cualquier consulta de un niño de primera infancia/adolescencia, sobre

todo si es delgado. Se aprecia como eyectivo, es decir R1, soplo creciente-decreciente y R2 estando bien separados los elementos. El R2 es normal. Se ausculta como un soplo “romboidal” con acmé mesosistólico (en el medio de la sístole). Es timpánico y parece una cuerda de piano vibrando. Su área es en el borde esternal izquierdo inferior y el resto del examen es normal.

Una característica muy importante de los SI es que prácticamente dejan de escucharse al incorporar al paciente (sentarlo o pararlo). Hay que recordar siempre esta maniobra. El soplo de una CIV no se modifica con los cambios de posición.

Este soplo se debe a vibraciones sistólicas que se producen normalmente en la salida del ventrículo derecho (VD).

2.- Soplo de eyección pulmonar

Se encuentra en lactantes y niños más pequeños que el anterior. Se ausculta en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón. El R2 está desdoblado normalmente. No se irradia a la espalda.

Lo producen vibraciones de la válvula pulmonar normal.

3.- Soplo sistólico periférico

Se ausculta en recién nacidos (RN) y primeros meses de vida, en el trayecto de las ramas pulmonares, siendo más nítido en las axilas y dorso. Es el único SI del RN, pero aquí no está demás la consulta al cardiólogo. Se debe al ángulo que hay entre las ramas pulmonares y el tronco pulmonar en los primeros meses de vida.

4.- Soplo supraclavicular

Este SI se escucha mejor en niños y adolescentes por encima de la clavícula a ambos lados, pero mejor a la derecha. Habitualmente son niños delgados. También puede sentirse en el hueco supraesternal. Es eyectivo “romboidal” como todos estos SI. Con la maniobra sencilla de auscultarlo en posición normal y luego con los brazos hiperextendidos hacia atrás, el soplo deja de escucharse o se atenúa francamente. Lo producen los vasos arteriales del cuello.

Soplo continuo

5.- Murmullo o zumbido venoso

Se escucha en niños de primera infancia a ambos lados debajo de las clavículas como un zumbido sistólico y diastólico que se siente mejor sentado y aumenta al rotar la cabeza hacia un lado.

Se atenúa o desaparece con 2 sencillas maniobras:

- a) Acostando al niño.
- b) Comprimiendo suavemente el cuello por encima del sitio donde está el estetoscopio, al interrumpir el flujo de la vena yugular interna. Es el único SI que aumenta al sentar al paciente.

Concepto número 2: ningún soplo inocente se ausculta sobre el borde esternal derecho. Todos se sienten a la izquierda del esternón, en las axilas o sobre las clavículas.

Obviamente que el examen de un niño en el consultorio se hace combinando los hallazgos de los 4 ítems: interrogatorio, inspección, palpación y auscultación.

Un punto importante: es necesario tomar la tensión arterial (TA) en cada consulta, utilizando los manguitos adecuados a cada peso. Puede ser imperioso tomar la TA también en los miembros inferiores cuando existe la sospecha de coartación de aorta.

Para hacer el diagnóstico diferencial con los SI, haremos una breve reseña de los soplos patológicos característicos de las siete CC más frecuentes y que pueden presentarse en el consultorio junto a algún dato adicional del examen.

1.- Comunicación interventricular (CIV)

El soplo es regurgitante “en barra”, partiendo junto al R1 y sosteniéndose hasta el R2. Su área de máxima auscultación es el mesocardio y borde esternal izquierdo medio. Se puede acompañar de frémito. Diagnóstico diferencial con SI vibratorio de Still, pero este es eyectivo y sin frémito.

2.- Conducto arterioso permeable (PDA)

Se siente como soplo sistodiastólico quedando el R2 dentro del soplo, sobre foco pulmonar, a veces acompañado de múltiples clicks. Los pulsos son saltones y en los lactantes pequeños pueden palparse fácilmente los pulsos interdigitales de manos y pies.

Diagnóstico diferencial con zumbido venoso.

3.- Comunicación interauricular (CIA)

La llave diagnóstica es el R2 desdoblado fijo y el soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. Puede parecer un SI de eyección pulmonar. La clave es el R2.

4.- Estenosis pulmonar (EP)

Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar: Diagnóstico diferencial con el SI. Suele acompañarse de un click expulsivo difícil de percibir por el pediatra.

5.- Estenosis aórtica (EAO)

Es soplo se siente mejor en segundo espacio intercostal a la derecha del esternón! Y hay frémito en el hueco supraesternal (importante).

6.- Coartación de aorta (CoAo)

Soplo eyectivo interescapular (auscultar espalda!) y basal. Ausencia de pulsos femorales!

7.- Tetralogía de Fallot (TF)

Cianosis o insaturación arterial (saturometría transcutánea!) con R2 único y apagado y soplo sistólico intenso sobre el borde esternal izquierdo alto y medio.

Arritmias

Un párrafo aparte para los casos en los que el pediatra ausculta una arritmia.

Cuando son latidos anticipados que desacomplan el ritmo cardíaco probablemente sean extrasístoles auriculares o ventriculares. Hay que enviar al niño al cardiólogo infantil pues solo el ECG es el que permitirá hacer el diagnóstico de certeza. Habitualmente no revisten gravedad. Pueden asociarse a parasitosis.

Una situación frecuente es la arritmia sinusal respiratoria, fenómeno absolutamente fisiológico, pero que en algunos casos puede ser acentuado, sobre todo cuando el paciente no está taquicárdico. Se perciben ciclos de aceleración (fase taquicárdica) durante la inspiración y desaceleración (fase bradicárdica) durante la espiración. Una maniobra sencilla es pedirle al niño que haga una apnea y se logra acentuar la base bradicárdica. Es normal y no amerita consulta especializada.

Conclusiones

Estas son las 10 preguntas que se debe hacer siempre el pediatra para no dejar pasar una CC:

1. ¿Tiene abombamiento precordial? NO
 2. ¿Hay latidos en el cuello? NO
 3. ¿Tiene pulsos femorales? SÍ
 4. ¿El pulso humeral es diferente al femoral? NO
 5. ¿Hay frémito en el hueco supraesternal? NO
 6. ¿Se palpa ampliamente el choque de la punta? NO
 7. ¿Hay frémito precordial? NO
 8. ¿Soplo sistólico que se atenúa al sentarlo? SÍ
 9. ¿El R2 se desdobra variable? SÍ
 10. ¿Tiene soplo en la espalda (interescapular)? NO
- NIÑO NORMAL

Bibliografía

-

Perloff JK. *Cardiopatías Congénitas. Diagnóstico clínico*. Buenos Aires: Médica Panamericana; 1981; p 15-32.

Park M. *Cardiología pediátrica*. Madrid: Elsevier; 2008; p. 3-39.

Gamboa R. *Cardiopatías congénitas en Branco Mautner. Cardiología* 2003; p 310-18.

Sánchez P. *Cardiología pediátrica, clínica y cirugía*. Buenos Aires: Salvat; 1986. P. 88-99.

*Dr. Ricardo Gamboa

Pediatra y cardiólogo infantil (SAP/SAC).

Ex Instructor de residentes del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, La Plata.

Ex Jefe Sección Cardiología Infantil de la Fundación Favalaro.

Actual Jefe de Servicio Cardiología Infantil Hospital El Cruce, Florencio Varela.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER



DRA. FLORENCIA MORENO*

DRA. EMILSE ANDREA CABALLERO**

DRA. MARÍA CECILIA MURRAY***

Como me enseñó hace muchos años mi maestro y amigo el Dr. Enrique Schvartman «El conocimiento de los hábitos y costumbres del enemigo son factores fundamentales para lograr derrotarlo en la batalla».

Agradezco mucho a quienes me convocaron a participar en esta publicación y también agradezco infinito a quienes la leerán y harán posible el diagnóstico oncológico en tiempo y forma.
Dra. Florencia Moreno

Generalidades

El cáncer infantil es una enfermedad rara que puede manifestarse inicialmente con los mismos síntomas que otros procesos frecuentes y benignos. Su diagnóstico precoz y la derivación oportuna a un centro especializado mejoran sustancialmente la respuesta terapéutica y el pronóstico.

Las madres con frecuencia refieren: “sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso”.

Los padres son en general los mejores observadores de los síntomas de sus hijos.

Los profesionales de Atención Primaria han de tener en cuenta la percepción y el conocimiento de los hijos por parte de sus padres a la hora de considerar una derivación, así como un niño

o adolescente que consulte en varias ocasiones (por ejemplo, tres o más veces) por la misma sintomatología sin tener un diagnóstico claro.

Una correcta anamnesis haciendo hincapié en antecedentes hereditarios podría orientar sobre síndromes de cáncer heredo-familiar y una historia clínica y examen físico completos, son esenciales y ante la sospecha es conveniente contactarse y derivar a un centro que cuente con oncología pediátrica.

Epidemiología

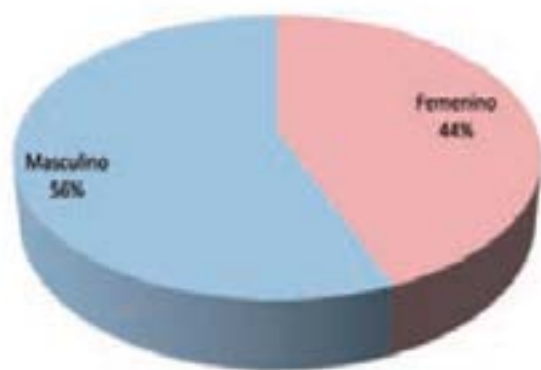
El Cáncer en el niño ocupa un lugar muy destacado dentro de la pediatría, por ser la 2ª causa de muerte en la infancia después de los accidentes. No existe diferencia global significativa respecto al sexo, y se puede presentar a cualquier edad, incluso en lactantes, RN y diagnosticarse intraútero.

El cáncer pediátrico no es prevenible pero se puede detectar oportunamente.

Entre los años 2000 y 2016, se reportaron al ROHA 22.450 casos de cáncer en niños menores de 15 años de edad. Las Leucemias constituyen la enfermedad oncológica más frecuente, seguida de los Tumores de Sistema Nervioso Central y los Linfomas. Esta distribución es similar a la descrita en los países desarrollados de Europa y Norte América.

Es la primera causa de muerte por enfermedad en el grupo entre los 5 – 15 años de edad, precedida por accidentes.

Los resultados de esta publicación indican que en la Argentina, la tasa de incidencia de cáncer en menores de 15 años durante el período 2000-2016 fue de 129,9 casos anuales por 1.000.000 de niños y se mantuvo estable a lo largo del período. La sobrevida estimada a los 5 años del diagnóstico para el período 2005-2011 fue aproximadamente del 66.5%. La sobrevida a 5 años de los tres tumores más frecuentes fue del 67.1% para las Leucemias, del 54.5% para los Tumores del Sistema Nervioso Central, y del 76.9% para los Linfomas. La tasa de mortalidad en el año 2012 fue de 4.4 por 100.000 en menores de 15 años, se estiman 450 muertes por año de cáncer (datos obtenidos del Registro Onco-pediátrico Hospitalario Argentino (ROHA).



La distribución del sexo en los niños con cáncer muestra una ligera predominancia para el sexo masculino. Aquí se muestra la frecuencia relativa para todas las patologías en un total de 15.092 niños en el período 2000 – 2011

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RETRASO DIAGNÓSTICO

La demora en la remisión de un paciente con cáncer y la iniciación tardía o suspensión del tratamiento pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La responsabilidad es de todos incluyendo a la familia que detecta los primeros signos y síntomas que la llevan a la consulta. La demora no debe generarse en los servicios de salud y ése debe ser nuestro compromiso con los niños.

Podemos dividir los tiempos y secuencias diagnósticas que atraviesan los niños, niñas y adolescentes con cáncer en cuatro períodos:

Primer Período

El primer período se extiende desde la aparición de los primeros signos o síntomas hasta la realización de la primera consulta con los padres o cuidadores del niño. En las primeras etapas muchos tumores son asintomáticos y el tiempo silencioso varía según la biología y la ubicación de cada tumor. En algún momento comienzan los signos o síntomas que pueden ser inespecíficos o por compresión o invasión de órganos. Muchas veces los síntomas se asemejan a los de las enfermedades comunes o molestias frecuentes y no siempre son tomados en cuenta por los padres. Esto depende de muchos factores: nivel de educación, información médica, escolaridad, creencias. En muchos casos la madre es la primera que detecta una tumoración, especialmente en lactantes (tumores abdominales, testiculares, etc.).

Segundo Período

El segundo período se extiende desde la primera consulta hasta la derivación a un centro especializado. Hay que tener en cuenta que el cáncer en pediatría es una rareza y la información que reciben los profesionales de salud es insuficiente. Es deseable que en los consultorios de atención primaria y/o urgencias se realice un examen físico completo, no limitándose a la revisión semiológica relacionada al síntoma por el que se consulta. Es muy importante que se examine a los niños de pies a cabeza, desnudos, procurando tomar la presión arterial y poniendo atención en lo que los padres y el niño relatan. Es fundamental que se eviten estudios e intervenciones, que puedan demorar un correcto diagnóstico. Ante la sospecha de patología tumoral es imperiosa la derivación inmediata a un centro especializado.

Tercer Período

El tercer período es aquel que transcurre desde el ingreso del niño a un centro especializado con sospecha diagnóstica de cáncer hasta la confirmación diagnóstica. La duración de este período va a depender de las características institucionales, que son muy dispares a lo largo del país. El circuito puede variar si el niño ingresa por el servicio de cirugía general, neurocirugía, endocrinología, psiquiatría, clínica. Es fundamental que en los centros de referencia trabajen con unidad de criterio ante la sospecha del niño con

cáncer, mantengan una comunicación fluida de los distintos servicios entre sí y con el servicio de hemato-oncología. Es indispensable que el oncólogo conozca al paciente ante la sospecha diagnóstica, ya que esta intervención previene demoras posteriores (pedidos de estudios para estadificación), mejora la precisión del diagnóstico (pedido de marcadores tumorales, etc.) o cambia la estrategia diagnóstica y terapéutica (utilizando punciones en lugar de biopsias a cielo abierto, evitando procedimientos agresivos, etc.). De esta manera se evita la pérdida de tiempo y recursos.

Cuarto Período

El cuarto período consiste en la instauración del tratamiento apropiado de acuerdo al diagnóstico y estadificación de la enfermedad.

Orientación diagnóstica

En la orientación diagnóstica en oncología pediátrica es muy importante tener en cuenta la edad ya que hay tumores que son más frecuentes en cada franja etaria. A continuación se adjuntan gráficos del ROHA (Registro Onco hematológico Argentino) que analiza los casos de cáncer en pediatría desde el año 2000 en niños, niñas y adolescentes en la Argentina.

Factores de riesgo en cáncer en pediatría

RADIACIONES IONIZANTES: La exposición a rayos X durante el embarazo podría aumentar el riesgo de cáncer de los niños productos de la gestación.

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEDICAMENTOS: Aunque no se ha demostrado de forma concluyente, algunos medicamentos podrían tener efecto carcinogénico en los niños cuando son administrados a la madre durante el embarazo; un ejemplo es el dietilbestrol, que se utilizó en los años setenta. Asimismo, la exposición a plaguicidas se ha asociado con leucemia, linfoma no Hodgkin y neuroblastoma, mientras que solventes como el benceno representan un factor de riesgo de leucemia en niños. El componente N-nitroso que se encuentra en algunos alimentos curados y el tabaco consumidos durante el embarazo pueden inducir tumores del sistema nervioso central (SNC), en tanto el alcohol y algunos diuréticos usados durante el embarazo han sido vinculados a tumores infantiles como

neuroblastoma y tumor de Wilms (4).

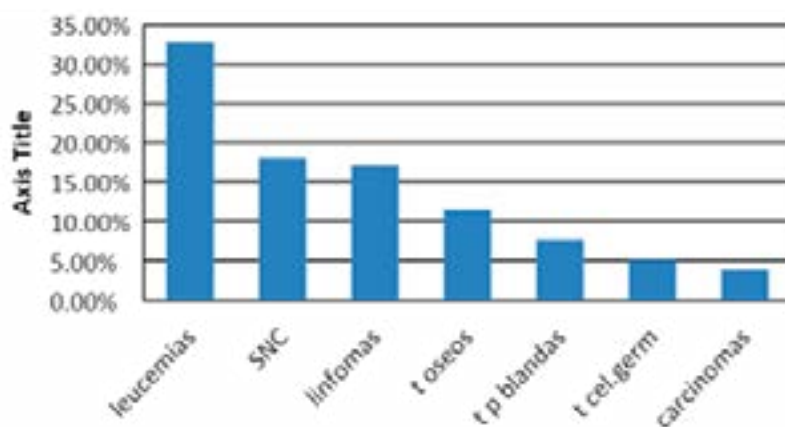
FACTORES BIOLÓGICOS: Algunos virus como el virus de Epstein Barr, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B y C, virus linfotrópico humano tipo 1 (HTLV1) y el papiloma virus están asociados con cánceres específicos, según el virus y los tejidos que afecta (4).

FACTORES GENÉTICOS FAMILIARES: En un 5-10% de los tumores subyace una base hereditaria. Entre los factores de riesgo familiares, los tumores embrionarios tienen dos formas de presentación: una heredada y una esporádica; no todos son heredados, pero dentro de los que lo son, el retinoblastoma y el tumor de Wilms bilateral son los más importantes. Algunos síndromes genéticos predisponen a padecer cáncer; los niños con Síndrome de Down, tienen un riesgo 20 a 30 veces mayor de padecer leucemia aguda; aquellos con síndrome de Klinefelter tienen un riesgo 20 veces mayor de tener cáncer de mama y luego un riesgo 30 a 50 veces mayor de presentar tumores de células germinales en mediastino. (1, 4).

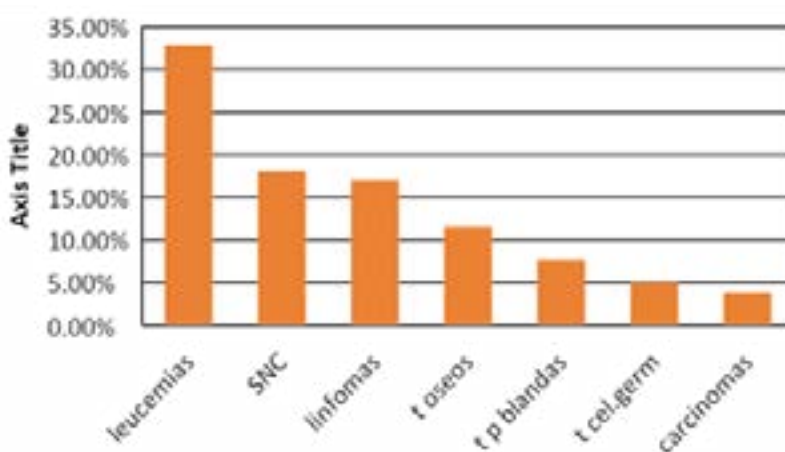
Es importante identificar a estos pacientes dado que podrían beneficiarse de medidas de prevención y detección precoz así como la posibilidad de consejo genético. Para esto la historia clínica es una herramienta fundamental, un buen interrogatorio con un familigrama que incluya 3 generaciones, con especial atención en la incidencia de cáncer en la familia, la ocurrencia del mismo tipo de enfermedad neoplásica, edad de presentación inusualmente temprana para el tipo de tumor, la bilateralidad en caso de afectación de órganos pares, la multifocalidad (varios focos tumorales independientes en el órgano donde asientan), la aparición de varios cánceres primarios en un mismo individuo o la asociación de cánceres con defecto del desarrollo (asociación de tumores con sobrecrecimiento corporal generalizado o asimétrico, dismorfias, malformaciones congénitas o retraso mental). En la tabla a continuación se detallan Síndromes de predisposición al cáncer y los tumores asociados (Tomada de Pediatría Integral 2016 SEHOP).

Signos y síntomas de alarma

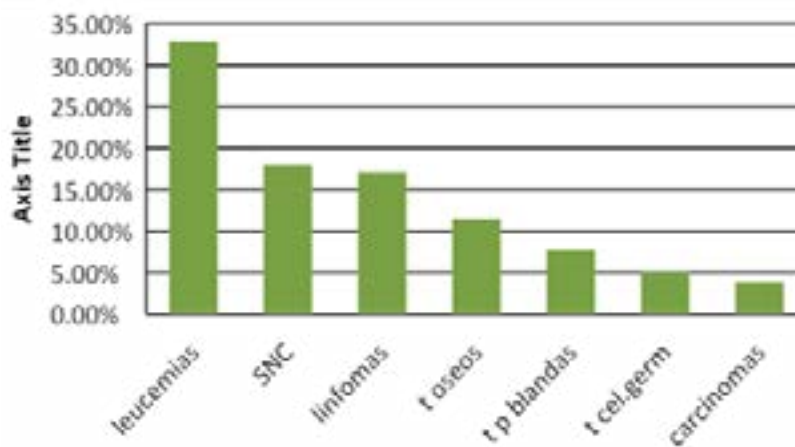
El cáncer infantil puede manifestarse en sus etapas iniciales con clínica similar a procesos frecuentes y benignos.



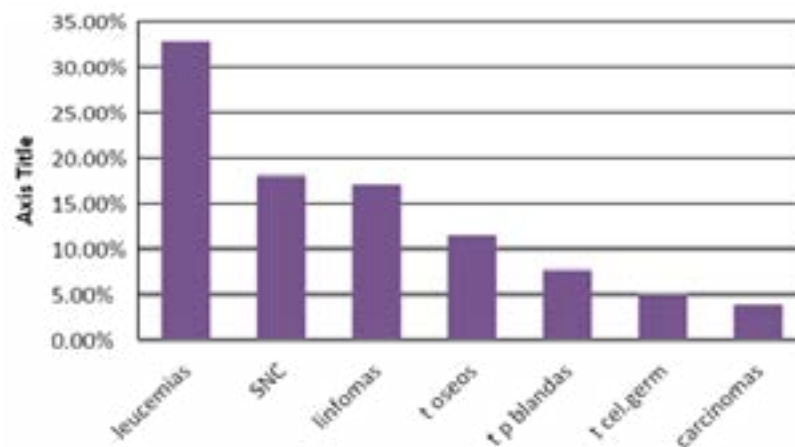
Distribución de Patologías de 0 a 1 año



Distribución de patologías de 1 a 4 años



Distribución de patologías 5 a 9 años



Distribución de patologías de 10 a 14 años

Tabla II. Síndromes de predisposición a cáncer y tumores asociados. Modificado de Alonso Sánchez MA, y cols.

Síndrome	Tumor	Síndrome	Tumor
Síndrome de Down	LMA, LLA	Neutropenia congénita severa	LMA
Síndrome de Turner	Células germinales, leucemia	Poliposis adenomatosa familiar	Meduloblastoma, carcinoma de colon, quistes epidermoides, osteomas, CFT, hepatoblastoma, tumores desmoides
Síndrome de Klinefelter	Adenocarcinoma mama, células germinales gonadal y extragonadal	Síndrome de Peutz-Jeghers	Colon-recto, estómago y duodeno, páncreas, mama, útero y gónadas
Trisomía 8	Nefroblastoma, células germinales extragonadal, leucemia, leiomiomasarcoma	Síndrome de Li-Fraumeni	SNC, LLA, sarcomas, melanoma, neuroblastoma, adenocarcinoma gi, carcinoma adrenocortical
Xeroderma pigmentoso	SNC, carcinoma, adenocarcinoma, células germinales, leucemia, melanoma y otros tumores de piel, RMS	Retinoblastoma hereditario	Retinoblastoma, sarcomas, pulmón, melanoma, leucemia LNH, SNC
Síndrome de Bloom	Carcinomas gi y piel, adenocarcinoma mamá y gi, LLA, LNH, cérvix	Neuroblastoma familiar	Neuroblastoma
Anemia de Fanconi	LMA, SNC, carcinoma de células escamosas, esófago, hepatocelular	Síndrome de Ondine	Neuroblastoma
Ataxia Telangiectasia	SNC, adenocarcinoma ovario y mama, linfoma, LLC, LLA, carcinoma gástrico, hepatocelular, melanoma, leiomiomasarcoma	MEN 1	Adenoma paratiroides, hipófisis, suprarrenal, gastrinoma, tumor carcinoide, lipomas, fibroangiofibroma facial
Esclerosis tuberosa	Renales, SNC, angiofibroma facial, adenoma tiroides, RMS	MEN 2A	Feocromocitoma, CMT, tumor paratiroides
Neurofibromatosis tipo 1	SNC, glioma óptico, neurofibroma medular, neurofibrosarcoma, feocromocitoma, paraganglioma, carcinoide	MEN 2B	CMT, feocromocitoma, neuromas cutaneomucosos
Neurofibromatosis tipo 2	SNC, neurofibroma, schwannoma vestibular	Melanoma maligno familiar	Melanoma, páncreas
Síndrome de Von Hippel-Lindau	Carcinoma renal, feocromocitoma, SNC, paraganglioma, hemangioblastoma	Síndrome de Denys-Drash	Tumor de Wilms, gonadoblastoma
Síndrome de Turcot	Adenocarcinoma de colon, glioblastoma, meduloblastoma, neuroblastoma, leucemia	Síndrome de Beckwith-Wiedemann	Tumor de Wilms, gonadoblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular, carcinoma adrenocortical, RMS
Complejo de Carney	Leiomioma útero, tiroideos, mixoma cardíaco, carcinoma adrenocortical, testiculares, hipófisis	Síndrome de WARG	Tumor de Wilms, gonadoblastoma
Síndrome de Cowden	Tiroides, mama, ovario, renales, endometrio, melanoma, SNC	Síndrome linfoproliferativo ligado al X	LNH
Síndrome de Diamond-Blackfan	Leucemia	Síndrome de Sotos	Tumor de Wilms
		Disqueratosis congénita	LH, carcinoma de células escamosas, páncreas

LMA: leucemia mieloide aguda. LLA: leucemia linfoblástica aguda. SNC: sistema nervioso central. RMS: rhabdomyosarcoma. gi: gastrointestinal. LNH: linfoma no Hodgkin. LLC: leucemia linfática crónica. CPT: carcinoma papilar tiroides. CFT: carcinoma folicular de tiroides. CMT: carcinoma medular de tiroides.

Es importante poder reconocer cuando esta sintomatología aparentemente benigna puede ser el inicio de una patología grave, así como identificar aquellos hallazgos que nos han de

poner en alerta ante la posibilidad de cáncer y que requieren estudio inmediato, por ello se debe escuchar a los padres que son los mejores observadores de los síntomas de sus hijos.

En la actualidad no existen métodos de cribado para el diagnóstico precoz del cáncer en los niños, con lo cual una historia clínica detallada y un examen físico completo de pies a cabeza con el paciente sin ropa sigue siendo nuestra mejor herramienta.

FIEBRE, PÚRPURA Y ANEMIA

Caso Clínico: Catalina de 5 años de edad acude a control con su pediatra de cabecera. La mamá refiere que Catalina desde hace una semana se encuentra decaída, sin ganas de jugar, algo pálida, y los últimos 3 días, al bañarla descubre hematomas en miembros inferiores y en abdomen inferior, no tiene recuerdos de que se haya golpeado.

Al examen físico, constata taquicardia 120 l/min, temperatura axilar de 38 °C, hematomas de diferentes tamaños y en diferentes estadios, localizados predominantemente en miembros inferiores y algunos dispersos en abdomen. Adenopatías cervicales bilaterales.

Laboratorio: Hemograma: GB: 2000 (fórmula: S30, L 70) Hb: 8 gr/dl, plaquetas 25000. El bioquímico informa células atípicas. Ante la sospecha de un debut leucémico el pediatra deriva a Catalina a un centro de mayor complejidad, donde se realizó la punción aspiración de médula ósea. (PAMO)

PAMO: se observa, infiltración de la médula ósea por 80 % de blastos de tipo linfoide.

La citometría de flujo confirma el diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B.

Fiebre, púrpura y petequias son síntomas frecuentes en las Leucemias Agudas. La fiebre persistente, sin un foco infeccioso debe hacer sospechar entre otras cosas una Leucemia Aguda.

La Leucemia Linfoblástica Aguda es el cáncer más frecuente en niños en pediatría, con aproximadamente el 37% de los casos de cáncer en niños en la Argentina.

Forma de presentación: es inespecífica con un período que va de días a semanas con cansancio, palidez, decaimiento, dolor osteoarticular intermitente, fiebre y en algunos casos puede presentarse con cuadros de mayor gravedad: infecciones severas o sangrados.

Examen físico: puede presentarse con palidez cutáneo-mucosa, sangrados húmedos o en piel (púrpuras, equimosis, petequias), hipertrofia de encías, hepatoesplenomegalia, adenomegalias

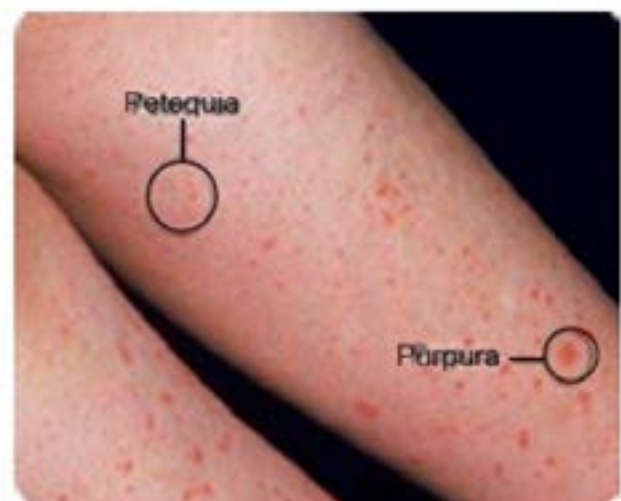
(cervicales, axilares, mediastinales, inguinales) agrandamiento testicular.

Diagnóstico: En la consulta por guardia y ante la sospecha, es fundamental solicitar un hemograma que sería ideal que fuera evaluado por un hematólogo, allí podremos observar alteraciones en al menos 2 de las tres series: bicitopenias (anemia, plaquetopenia) o en las tres: pancitopenias (leucopenia, anemia, plaquetopenia) o en aumento importante en los glóbulos blancos a expensas de formas atípicas: blastos, sumado a la alteración de alguna de las otras series.

Estos pacientes deben ser derivados con urgencia a un centro que cuente con onco-hematólogo pediatra que pueda realizar una punción aspiración de médula ósea que será procesado en un laboratorio especializado para realizar Inmunomarcación por citometría de flujo, estudio citogenético y biología molecular, además de la morfología del material en microscopía óptica evaluado por un Hemato-oncólogo pediatra. Esto nos discrimina entre Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B o T (LLA B o T) o de una Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y qué subtipo.

Tratamiento: Debe llevarse a cabo en un centro especializado que cuente con hemato-oncólogo pediatra y sala de internación acorde para albergar a estos pacientes durante el mismo. Este se lleva a cabo con quimioterapia que difiere de acuerdo al tipo de leucemia, la duración es de 18 meses en las LMA (leucemia mieloide aguda) y de 24 meses en las LLA (leucemia linfoblástica aguda), algunos casos particulares requieren trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).

Figura # 1. Petequias y purpura



Criterios de referencia: algoritmo leucemia/linfoma



Entre el 40 y 80% de los niños se curan y esto depende del tipo de leucemia, de las características de la Institución tratante, del paciente y del grupo familiar.

CEFALEA Y VÓMITOS: TUMORES CEREBRALES

Caso clínico: Pedro de 8 años de edad, acude a la guardia del Hospital Materno infantil, por presentar cefalea frontal intensa, con una evolución de 15 días. En las últimas 72 hs, también presentó vómitos al levantarse a la mañana.

Pedro vive con su abuela, porque sus padres biológicos no pueden hacerse cargo de su cuidado.

La abuela refiere, que la cefalea se presenta 2 veces por día, y que inicialmente cedía con analgésicos o con el descanso. Consulta ya que nota que el dolor aumentó en intensidad y en frecuencia, en ocasiones Pedro se despertaba durante la noche por el dolor, la preocupación de la abuela surge cuando se agregan los vómitos.

Al examen físico Pedro presenta una facies de dolor, fotofobia y durante el examen físico presenta un vómito en chorro; debido a la evolución, se solicita una TAC de cerebro, de urgencia, donde se visualiza una masa ocupante en fosa

posterior. Pedro es ingresado en internación, tras la consulta con el servicio de neurocirugía y oncología, se programa realizar biopsia y cirugía.

La anatomía patológica reveló el diagnóstico de MEDULOBLASTOMA CLÁSICO.

Los tumores cerebrales son los segundos en frecuencia en la niñez detrás de las Leucemias.

Las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales dependen de dos factores:

- Localización del tumor
- Aumento de la presión endocraneana

La localización más frecuente de los tumores es la fosa posterior siendo los astrocitomas, meduloblastomas, ependimomas y los tumores de tronco las neoplasias más comunes. Estos tumores pueden cursar con hidrocefalia que es una de las causas más frecuentes del dolor de cabeza. Es importante tener en cuenta las características de la cefalea. El dolor generalmente progresa en el tiempo, con períodos en los que puede remitir, aunque el dolor reaparece, pudiendo ser más intenso en las noches (lo despierta) o por las mañanas. En las situaciones de aumento de la presión abdominal (defecación) el dolor puede incrementarse. El dolor de cabeza puede acompañarse de vómitos que pue-

den ser en chorro, matutinos y sin sensación de náuseas. Estas manifestaciones (cefaleas y vómitos) pueden corresponder a la presencia de hipertensión endocraneana. En los lactantes es muy difícil identificar el dolor de cabeza, en general se manifiesta como un lactante irritable, con retraso en la adquisición de pautas madurativas para la edad, falta de progreso de peso, vómitos, aumento del perímetro cefálico, separación de las suturas y abombamiento de la fontanela anterior, por lo cual el control del perímetro cefálico es imperioso. En los niños en edad escolar pueden manifestarse con deterioro en el rendimiento escolar, hiperfagia (localización en hipotálamo), cambios de conducta.

Las convulsiones son un signo de presentación de tumores de SNC a cualquier edad que generalmente se asocian a tumores supratentoriales.

Ante la presencia de un niño con cefalea o cualquier síntoma sospechoso de tumor en sistema nervioso central es mandatorio la derivación a un centro de alta complejidad que cuente con neurocirujano con experiencia en Oncología Pediátrica sin pérdida de tiempo y sin necesidad de estudios.

Diagnóstico: Además del examen físico completo y la historia clínica detallada, el diagnóstico a través de imágenes debe ser supervisado por el Oncólogo Pediatra y el Neurocirujano con TAC o RMN de cerebro.

Tratamiento: Depende del tipo de tumor, pero en general el tratamiento es el control local de la enfermedad con cirugía en manos de un neurocirujano con experiencia en Oncología pediátrica en un centro con la complejidad adecuada que

cuente con Oncólogo pediatra para continuar y supervisar el tratamiento posterior al quirúrgico con radioterapia y quimioterapia.

Existen tumores, que por su localización, no pueden tratarse con cirugía (tumores de tronco, gliomas del nervio óptico) en estos casos la radioterapia y quimioterapia ayudan a controlar la enfermedad.

AUMENTO DEL TAMAÑO GANGLIONAR

Caso clínico: Patricia de 14 años, presenta tos seca de 14 días de evolución, sin fiebre, consultó por guardia en varias oportunidades. La mamá refiere que no mejora, que está preocupada e insiste en que se le realice una radiografía de tórax.

Al interrogatorio dirigido, Patricia refiere que de noche le cuesta conciliar el sueño porque tiene sensación de falta de aire.

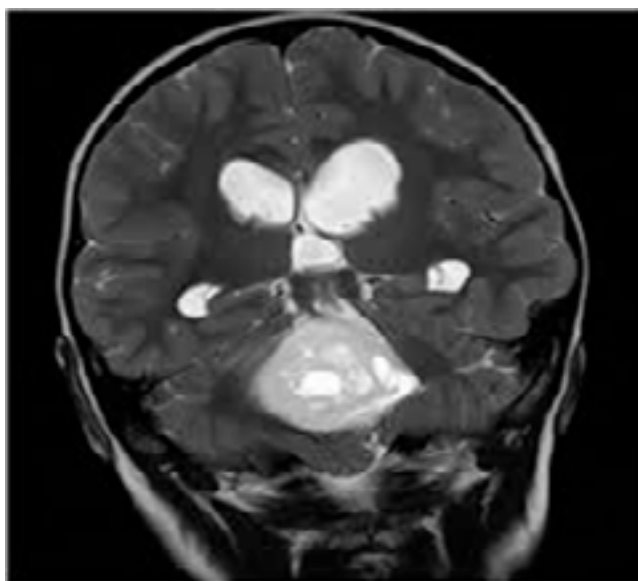
Al examen físico se encuentra en buen estado general, afebril, eupneica, a la auscultación pulmonar se constata buena entrada de aire sin ruidos agregados.

Hemograma: Gb:11000 (s70, l 30), Hb 10 gr/dl, plaquetas: 300.000

RX tórax: se observa ensanchamiento en mediastino

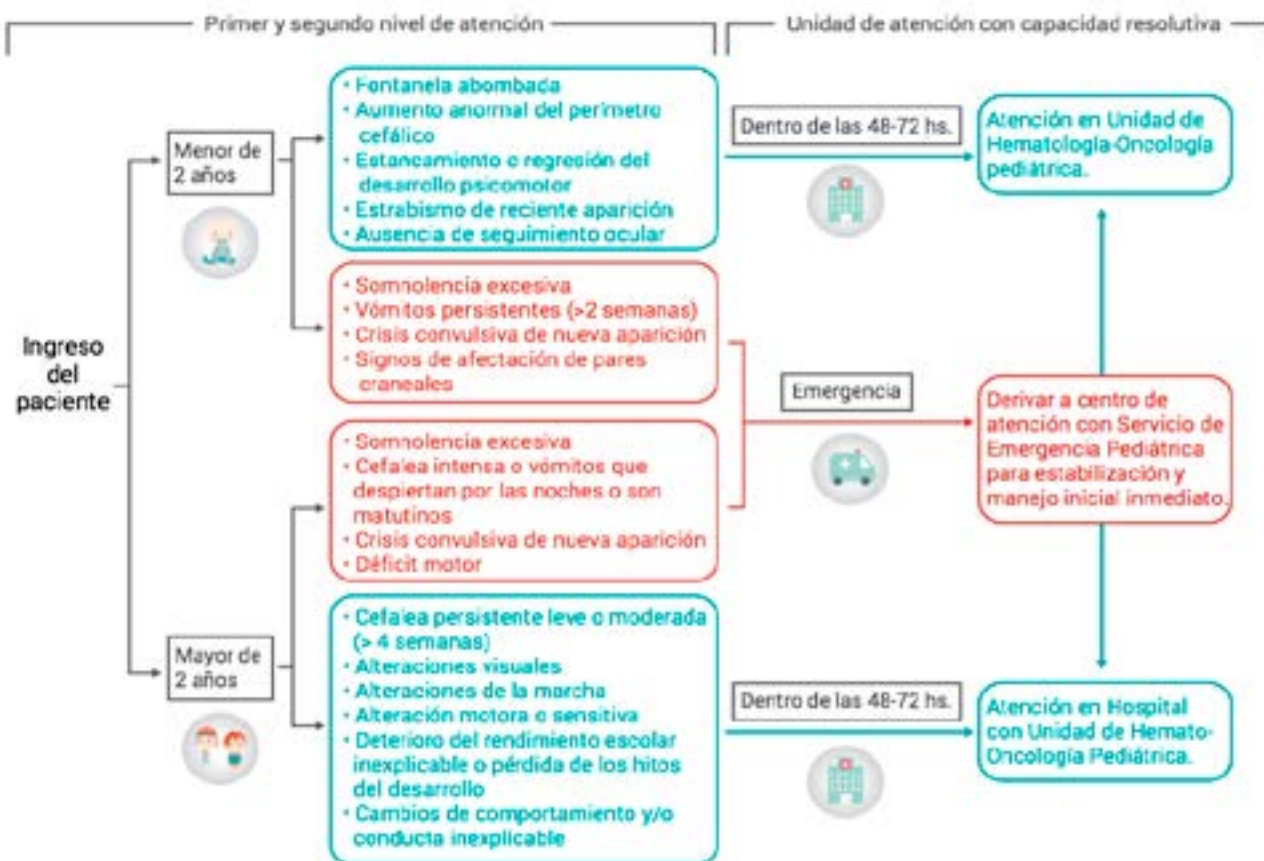
Rx tórax perfil: Impresiona masa en mediastino anterior

Es derivada a un centro de mayor complejidad, donde se le realiza TAC de tórax, y se realiza biopsia de mediastino. Se envía muestra a anatomía patológica y para inmunomarcación por citometría de flujo. Ambas confirman el diagnóstico de Linfoma Linfoblástico T.



Los ganglios linfáticos son estructuras dinámicas que cambian de tamaño durante el crecimiento, generalmente, en respuesta a infecciones. La mayoría de los niños presentan pequeños ganglios palpables a nivel cervical, axilar o inguinal. Se considera significativo el aumento de tamaño por encima de 1 cm de diámetro en ganglios cervicales y axilares, 1,5 cm en los inguinales y 0,5 cm en los epitrocleares. Las adenopatías son generalizadas cuando se extienden en más de 2 cadenas ganglionares no contiguas y localizadas, cuando aparecen en una única región, como el cuello o la axila. Según el tiempo de evolución, distinguimos entre: agudas (menos de 2 semanas), subagudas (en-

Criterio de referencia: algoritmo de tumor cerebral



tre 2-6 semanas) y crónicas (más de 6 semanas). Las neoplasias más frecuentes que se presentan como adenopatías en cabeza y cuello son:

- Menores de 6 años: neuroblastoma, leucemia, rabdomiosarcoma y linfoma no Hodgkin
- Entre 7 y 13 años: linfomas de Hodgkin y no Hodgkin
- Mayores de 13 años: linfomas de Hodgkin

La exploración física será completa buscando: signos de enfermedad sistémica, lesiones cutáneas, palidez, hematomas, petequias, lesiones orofaríngeas, conjuntivales o auditivas, hepatoesplenomegalia y masas abdominales. Las adenopatías serán evaluadas en función de su localización, tamaño, dolor, consistencia y fijación a tejidos. Se deben palpar, de forma sistemática, todas las cadenas ganglionares accesibles: occipital, retroauricular, preauricular, parotídea, tonsilar, submandibular, submental, caras anterior y posterior de cuello, supraclavicular, infraclavicular, axilar, epitroclear, inguinal y poplíteo. En cuanto a los factores predictivos de malignidad,

la mayoría de los autores concuerdan en que los ganglios con un tamaño mayor de 3 cm, localización supraclavicular o generalizada, adherencia a tejidos circundantes, no dolorosos, la asociación a hepatoesplenomegalia y síndrome de repercusión general (adelgazamiento, astenia, fiebre de origen desconocido), aumento de LDH, deberían generar alarma y solicitar la consulta con cirujano pediatra para discutir la realización de una biopsia.

Los linfomas se manifiestan con agrandamiento ganglionar y son la tercera patología oncológica más frecuente y representa el 13% de los casos de cáncer en Argentina, siendo la mayor incidencia en niños mayores de 10 años. Se presentan con adenopatías de crecimiento rápido en el caso de Linfomas no Hodgkin y crecimiento más lento en caso de Linfoma Hodgkin, éste último puede asociarse a pérdida de peso, sudoración nocturna, prurito y fiebre inexplicada.

El linfoma no Hodgkin se manifiesta con distensión y dolor abdominal, vómitos, disnea (en caso de masa ganglionar mediastinal).

Examen físico:

LINFOMA HODGKIN: adenopatías no dolorosas que forman conglomerados, no dolorosas que se adhieren a planos profundos, importante realizar un buen interrogatorio en busca de síntomas B: fiebre, pérdida mayor al 10% del peso, prurito y sudoración nocturna. El prurito es un motivo de consulta frecuente para el dermatólogo pediatra, cuando el prurito persiste en el tiempo, es muy extendido y sin causa que lo justifique hay que considerarlo un síntoma paraneoplásico. La sudoración nocturna sin causa que lo justifique (el paciente moja la cama y requiere cambiarse la ropa en mitad de la noche) debe hacer pensar en linfoma Hodgkin.

LINFOMA NO HODGKIN: masas abdominales en región ileocecal, que puede ir acompañada de historia de constipación y dificultad respiratoria cuando la localización es torácica.

Diagnóstico:

Radiografía de tórax: Al solicitar un estudio de imágenes es fundamental reconocer la calidad del mismo para obtener la información correcta y también conocer los hallazgos normales para tener el alerta adecuado cuando se encuentra patología. Esto se aplica a prácticas tan simples como la radiografía de tórax o las radiografías óseas. ¿Cómo reconocemos la calidad técnica de una RX de tórax?

Los factores para evaluar la calidad técnica de una Rx de tórax son:

- Inspiración: Nivel en que se encuentran los diafragmas en relación a los espacios intercostales: Inspiración máxima (antes de iniciar el grito de llanto): 10 espacio intercostal
- Penetración: ver la columna a través del corazón
- Rotación: apófisis espinosas y clavículas equidistancia entre extremos de las clavículas así como de los extremos anteriores de las costillas y las apófisis espinosas vertebrales.
- Angulación del tubo de rayos: extremidad interna de clavículas debe proyectarse a la altura de la 3ª costilla.

Se aconseja hacer una evaluación sistemática rutinaria de las estructuras del tórax, por ejemplo de afuera hacia adentro: partes blandas, óseas, senos costofrénicos, parénquima pulmonar y mediastino. Tener conocimiento del signo

de la silueta: Cuando dos estructuras de igual densidad se encuentran en el mismo plano, se borran sus contornos. La radiografía de perfil facilita la localización de las masas mediastinales.

Tener en cuenta que la presencia del timo normal en los neonatos y lactantes opacifica el espacio aéreo retroesternal que se visualiza en adolescentes y adultos. Frecuentemente es interpretado erróneamente como masa mediastinal anterior.

La ecografía es un método relativamente accesible muy útil en la evaluación del hemitórax grande y opaco, permitiendo una evaluación rápidamente orientadora. También puede ser utilizado en los casos de duda diagnóstica en relación a la imagen tímica.

Los tumores mediastinales deben hacer sospechar una neoplasia. Es necesario tener en cuenta la disnea progresiva en este contexto y la evolución atípica de una neumopatía. Los diagnósticos más frecuentes a tener en cuenta son: los linfomas, los neuroblastomas y las leucemias.

Ante la sospecha por radiografía simple de tórax de masa tumoral debe derivarse en forma urgente a un centro con servicio de hemato-oncología infantil. No se deben solicitar estudios de mayor complejidad.

MASAS ABDOMINALES

Todo paciente con masa abdominal ha de ser valorado bajo sospecha de malignidad. Las masas localizadas en el cuadrante superior derecho suelen tener un origen hepático, renal o adrenal. Las masas del cuadrante superior izquierdo con frecuencia dependen del bazo y pueden ser causadas por infiltración metastásica. Las masas abdominales bajas suelen ser secundarias a tumores ováricos o a linfoma intestinal. La masa abdominal es con frecuencia detectada por los padres o cuidadores. En la anamnesis, tendremos en cuenta la edad del paciente por sus consideraciones diagnósticas.

NEUROBLASTOMA

Caso clínico:

Tahiel de 15 meses de edad, es llevado a la consulta con el oftalmólogo, porque su madre refiere que observa un hematoma en región orbitaria derecha.

El oftalmólogo realiza un fondo de ojo donde no observa alteraciones y observa desplazamiento del globo ocular. Se decide su internación para estudio.

Al examen físico se encuentra pálido, en regular estado general, presenta dolor al movilizarlo, sobre todo localizado en cadera izquierda. A la palpación profunda abdominal, se constata la presencia de una masa dura en flanco izquierdo.

Laboratorio: Gb: 10500, Hb: 7 gr/dl, Plaquetas 250.000, Función renal y Hepatograma dentro de límites normales.

Se solicitan estudios de imágenes.

TAC de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso: Se observa una masa retroperitoneal impresiona suprarrenal izquierda, con algunas calcificaciones en su interior y que realza con el contraste. Imágenes líticas a nivel de isquion y acetábulo de cadera izquierda.

TAC de cráneo y órbita: se observa una masa por detrás del globo ocular derecho que infiltra partes blandas alrededor del globo ocular y lo desplaza hacia adelante.

Se realiza biopsia de la masa suprarrenal y punción biopsia de médula ósea.

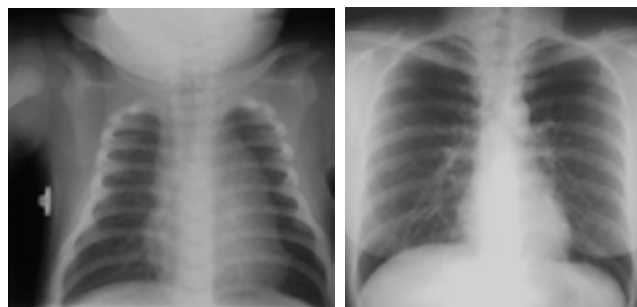
La anatomía patológica informa NEUROBLASTOMA.

Representa el 6 % de los tumores en niños en la Argentina con mayor incidencia en menores de 4 años. Esta patología afecta los ganglios del sistema simpático incluyendo la glándula suprarrenal en el 75% de los casos; puede presentarse como masas abdominales, torácicas o medulares con compromiso neurológico al afectar el canal vertebral. En su forma “abdominal” se localiza en la región retroperitoneal, atraviesa la línea media. En su forma metastásica pueden aparecer con nódulos subcutáneos, exoftalmos, opsomoclonus, palidez y equimosis periorbitaria, signo del “ojo de mapache”.

Diagnóstico:

El diagnóstico se realiza

- Clínica
- Biopsia de la masa tumoral que debe ser lle-



Rx Recién nacido.

Decúbito supino PA Distancia tubo 1.80 m



RX de Tórax Perfil normal: Compartimientos mediastinales

A : Anterior M: medio P: posterior



Imágenes de timo en lactante



Neuroblastoma

Signo de la silueta

vada a cabo por un cirujano pediatra con experiencia en oncología pediátrica, si el paciente tiene compromiso en médula ósea el diagnóstico puede realizarse con esta muestra.

-Ante la sospecha de Neuroblastoma este paciente debe ser derivado a un Centro que cuente con Hemato-oncología pediátrica, Cirugía Pediátrica y diagnóstico por imágenes:

-Ecografía, es útil en el diagnóstico y la evaluación de la masa

RMN y/o TAC de abdomen y pelvis son útiles en la evaluación de la masa, su relación con los grandes vasos y órganos vecinos, orientan a la localización, planificación quirúrgica y estadificación

-Centellograma con MIBG: (Meta iodo bencil guanidina) Se trata de un análogo de noradrenalina que es captado a nivel presináptico por el transportador de noradrenalina (NAT). Es útil para evaluar metástasis.

Tratamiento:

Se basa en la quimioterapia, cirugía y radioterapia, los pacientes de alto riesgo tienen indicación de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.

El pronóstico depende del estadio de la enfermedad al diagnóstico, siendo los tumores de mejor pronóstico los que se presentan en menores de un año que inclusive pueden remitir espontáneamente.

TUMORES RENALES

Caso Clínico:

Joaquín de 2 años es llevado por sus padres a su pediatra de cabecera ya que desde hace una semana notan un crecimiento progresivo del abdomen.

Al examen físico Joaquín se encuentra en muy buen estado general, peso y talla acorde a edad, febril.

A la palpación abdominal se constata una masa nivel de flanco derecho.

Se solicita ecografía abdominal que informa una tumoración renal derecha hiperecogénica. Se completan estudios diagnósticos: TAC de abdomen con contraste oral y endovenoso: se evidencia una masa en polo superior derecho del riñón heterogénea, con áreas de sangrado y necrosis. Dg de sospecha: TUMOR DE WILLMS.

Los tumores renales representan el 5% de los tumores en niños en Argentina, siendo el más

Tabla 1. Distribución de diagnósticos de acuerdo a la edad

Menor a 1 año (n=7)	1-5 años (n=13)	5-10 años (n=12)	Mayor a 10 años (n=8)
Wilms	Wilms	Germinales	Burkitt
Neuroblastoma	Burkitt	Wilms	Wilms
Hepatoblastoma	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Germinales
	Germinal	Sarcoma partes blandas	Neuroblastoma
	Hepatoblastoma		
	Adenocarcinoma suprarrenal		

Tabla VI. Masas abdominales benignas y malignas en función de su localización

Localización	Maligno	Benigno
Abdomen superior	Tumor de Wilms Neuroblastoma Leucemia/linfoma Hepatoblastoma Carcinoma hepatocelular Tumor células germinales Sarcomas Nefroma mesoblástico	Hidronefrosis Riñón multiquistico poliquístico Trombosis vena renal Hemorragia adrenal Estenosis pilórica Esplenomegalia Quiste de colédoco Enfermedades de depósito
Abdomen medio	Linfoma no Hodgkin Neuroblastoma/PNET Tumor células germinales Sarcomas	Duplicación intestinal Quiste mesentérico Invaginación intestinal Hiperplasia linfoide Plastrón apendicular Contenido fecal/meconio Ascaris
Abdomen inferior y pelvis	Tumores ováricos Tumores germinales Sarcomas	Obstrucción urinaria Quiste ovárico Hidrometrocolpos Mielomeningocele anterior Embarazo Enfermedad inflamatoria pélvica

PNET: tumor primitivo neuroectodérmico periférico.



frecuente el tumor de Wilms (90%) con la mayor incidencia en menores de 4 años. Son niños que se encuentran en buen estado general y que sus padres palpan una masa abdominal al cambiarlos o bañarlos o puede presentarse con hematuria. Al examen físico se constata una masa palpable que no atraviesa la línea media, puede causar hipertensión arterial.

Ante la sospecha debe derivarse al paciente a un centro que cuente con hemato-oncólogo pediátrico, cirujano pediátrico.

Diagnóstico:

Se basa en:

- Clínica
- Estudios por imágenes: Ecografía
- RMN de abdomen y pelvis (evaluación de la masa. Relación de la masa con grandes vasos y búsqueda de metástasis en hígado ganglios linfáticos del abdomen y pelvis)
- TAC de tórax (búsqueda de metástasis pulmonares)
- Anatomía patológica: otorga el diagnóstico definitivo se lleva a cabo luego de la cirugía de resección. En algunos casos que no responden a la quimioterapia preoperatoria se lleva a cabo la punción biopsia de la masa tumoral, la misma es desaconsejada de rutina porque cambia el estadio de la enfermedad por ruptura de la cápsula tumoral.

Tratamiento:

- Quimioterapia preoperatoria: tiene como finalidad reducir la masa tumoral disminuir el riesgo de ruptura tumoral durante la cirugía
- Cirugía: resección tumoral y envío de la muestra a anatomía patológica.
- Quimioterapia post operatoria: se adapta a la anatomía patológica, estadio de la enfermedad

TUMORES HEPÁTICOS

Caso Clínico:

Bautista de 11 meses de edad, se encuentra en seguimiento por su pediatra de cabecera por curva de peso y talla detenidas, continúa con lactancia materna y alimentación mixta.

Al examen físico su pediatra constata que no hubo aumento de peso con respecto al control del mes anterior, y a la palpación abdominal, encuentra una masa abdominal en flanco derecho

Solicita una ecografía urgente: que informa masa hiperecogénica hepática, solicita la derivación urgente a un centro de mayor complejidad para estudio diagnóstico y tratamiento.

En el hospital de referencia, el oncólogo pediátrico completa los estudios solicitando laboratorios, entre ellos alfa feto proteína que se encuentra elevada, RNM con gadolinio, eviden-

Criterios de referencia: algoritmo de masa abdominal, neuroblastoma y tumor de Wilms



CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS: TUMOR DE WILMS VS NEUROBLASTOMA		
CARACTERÍSTICA	TUMOR DE WILMS	NEUROBLASTOMA
Edad	2 – 5 años	< 2 años
Órgano de origen	Riñón (es)	Tejido de la cresta neural (Retroperitoneo)
Letalidad	5-10%	85-95%
Calcificaciones	5-10%	85-95%
Efecto de masa	Intrarrenal (signo de gancho)	Compresión extrínseca
Invasión local	Desplaza vasos renales Extensión directa hacia la vena renal, VCI y AD	Encierra y desplaza vasos Extensión al agujero neural
Sitios de metástasis	Pulmón	Hueso

Ultrasonido Clínico – 3ra Edición, 2014 Paul L. Alton - Grant M. Barker - Michael J. Weston

ciado una masa hepática hipertensa en t1 y t2. Se realiza biopsia hepática: el estudio de anatomía patológica confirma el diagnóstico de HEPATOBlastoma FETAL.

Los tumores hepáticos constituyen aproximadamente el 1% de los tumores pediátricos, y la tercera neoplasia intraabdominal más frecuente, siendo el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular los más diagnosticados.

Los tumores hepáticos pueden ir asociados a síndrome genéticos: Poliposis adenomatosa familiar, Síndrome de Li Fraumeni, Trisomía 18 y la glucogenosis tipo I. La infección por virus de hepatitis B en período neonatal predispone al desarrollo de hepatocarcinoma.

Los recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de desarrollar hepatoblastoma.

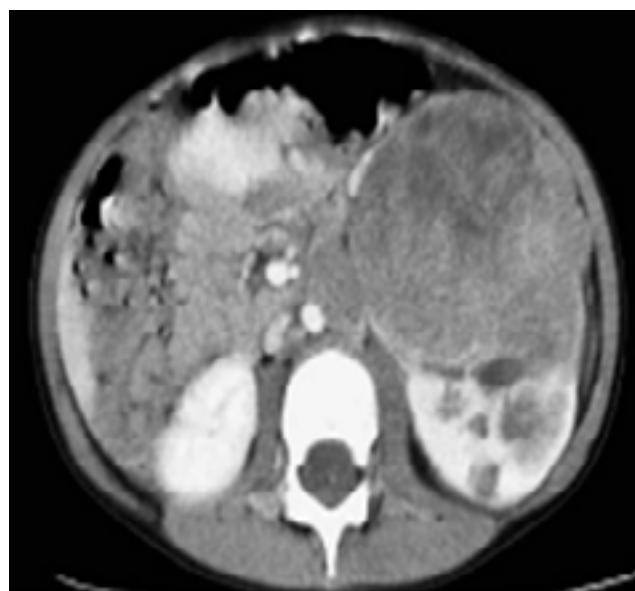
HEPATOBlastoma

Se presenta en lactantes y niños entre los 6 meses y 5 años de edad.

Se asocia a pérdida de heterocigosidad de 11p15 que se observa en 33% de los pacientes, esta alteración es de origen materno y es patognomónica del Síndrome de Wiedeman-Beckwith, asociada con mayor riesgo a desarrollar tumor de Willms, hepatoblastoma y rhabdomyosarcoma.

Diagnóstico

Clínica: La mayoría de los pacientes se presen-



tan con una masa abdominal asintomática, la presencia de fiebre, dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso es sugestiva de enfermedad avanzada. Aproximadamente un 20% de los pacientes se presentan con enfermedad metastásica al diagnóstico, siendo más frecuentes las metástasis pulmonares, pero se han descrito en sistema nervioso central y óseas.

Laboratorio: en el hemograma se detecta anemia y trombocitosis (asociada a elevados niveles de trombopoyetina en estos pacientes)

-Alfa fetoproteína: es un marcador muy sensible pero no específico, que se encuentra elevado en el 90% de los pacientes, tiene utilidad en el monitoreo de la eficacia terapéutica y de la recurrencia de la enfermedad.

-Imágenes: Los estudios por imágenes son útiles para la evaluación de la masa tumoral, su extensión en los segmentos hepáticos y decisión terapéutica.

-Ecografía: es de suma utilidad en el primer nivel de atención, cuando el médico pediatra por clínica detecta una masa abdominal, la ecografía otorga información sobre la localización.

Ante un paciente con una masa abdominal, de localización hepática, es importante que se derive lo más pronto posible a un Centro de Alta Complejidad que cuente con cirugía pediátrica con experiencia en cirugía hepática y oncólogo pediatra.

TAC Y RMN: Las técnicas de imagen tienen un papel fundamental en el diagnóstico, estadío y tratamiento de los pacientes. Permiten determinar los segmentos afectados y la topografía exacta para la planificación quirúrgica del tumor.

Tratamiento:

Quimioterapia preoperatoria: tiene como finalidad reducir la masa tumoral para disminuir el riesgo de complicaciones quirúrgicas

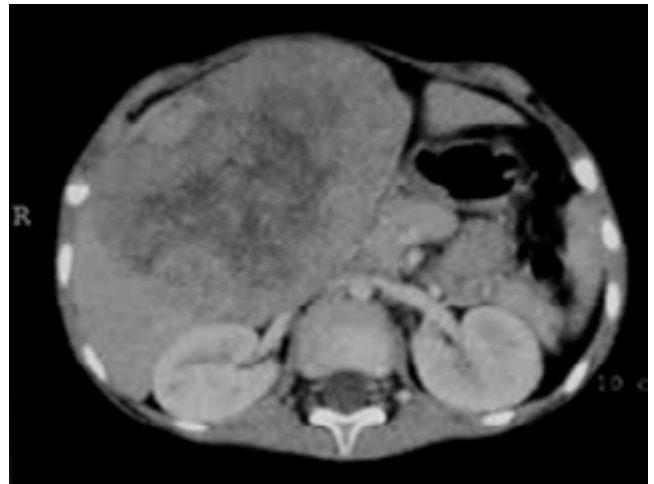
Cirugía constituye la piedra fundamental para el tratamiento y debe estar a cargo de un equipo quirúrgico capacitado en cirugía de hígado y vías biliares. La resección completa del tumor es un paso fundamental para lograr la curación de la enfermedad.

Quimioterapia post-operatoria: tiene como finalidad consolidar el tratamiento de la enfermedad y disminuir la posibilidad de recidiva y de metástasis a distancia.

LEUCOCORIA: RETINOBLASTOMA

Caso clínico:

Francisco de 4 meses de vida es derivado al oftalmólogo por presentar alteración en el reflejo rojo pupilar del ojo izquierdo (leucocoria), acompañado de estrabismo divergente homolateral. Fue evaluado por oftalmología y derivado con urgencia a un centro de mayor complejidad por sospecha de retinoblastoma de ojo izquierdo. Al examinar fondo de ojo se encontró lesión de 4 mm que ocupa 2/3 partes de la retina, por lo que se realizó TAC cerebral y de órbita de ojo izquierdo, que reportó hipotrofia cortical frontotemporal bilateral y masa sólida calcificada que no se extiende fuera del globo ocular. Se



indicó RMN de órbita, encontrándose masa hipodensa irregular en cámara posterior de ojo izquierdo. Posteriormente se realizó retino cámara, mostrando lesión que cubre casi la totalidad de la retina. Con estos hallazgos fue intervenido quirúrgicamente por el Servicio de Oftalmología realizando enucleación del ojo afectado, la anatomía patológica confirmó el diagnóstico de retinoblastoma unilateral.

Leucocoria significa “mancha blanca en la pupila” y es el principal signo de retinoblastoma, este signo muchas veces se hace evidente en fotografías tomadas con flash. Tanto la leucocoria como el estrabismo son signos que requieren la derivación a un oftalmólogo pediatra.

El retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente y representa el 3-4% de los tumores en Argentina y la mayor incidencia se observa en menores de 2 años de edad. 25% son hereditarios.

Diagnóstico:

Clínica: Es importante explorar el reflejo rojo pupilar en los recién nacidos como parte del examen físico en los controles de salud, la ausencia de dicho reflejo debe orientarnos a consultar al oftalmólogo pediatra y puede ayudarnos a llegar al diagnóstico precoz de retinoblastoma.

La leucocoria que puede ser notada por los padres como una opacidad en las pupilas o la ausencia del reflejo rojo pupilar que se observa en las fotografías con flash también orientan a este diagnóstico.

Diagnóstico Diferencial: cataratas congénita.

Tratamiento: el tratamiento se fue modificando en la última década. Históricamente la enucleación en muchos de los casos era el tratamiento

de rutina. Actualmente se está implementando en centros de alta complejidad la quimioterapia intra arterial, intraocular para poder salvar el ojo afectado, con muy buenos resultados siendo la Argentina los vanguardistas de esta tecnología. En los países que no cuentan con esta técnica la enucleación junto con quimio y/o radioterapia siguen siendo el tratamiento de elección. El 95% de los niños se curan. La curación depende del estadio de la enfermedad al diagnóstico, de la derivación oportuna y de la experiencia del Centro Médico tratante.

ANTE LA SOSPECHA DE RETINOBLASTOMA EL PACIENTE DEBE SER DERIVADO AL OFTALMÓLOGO PEDIATRA. EL TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA ESTÁ CENTRALIZADO EN CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD CON OFTALMÓLOGOS Y ONCÓLOGOS CON EXPERIENCIA EN TRATAR ESTA ENFERMEDAD.

DOLOR ÓSEO:

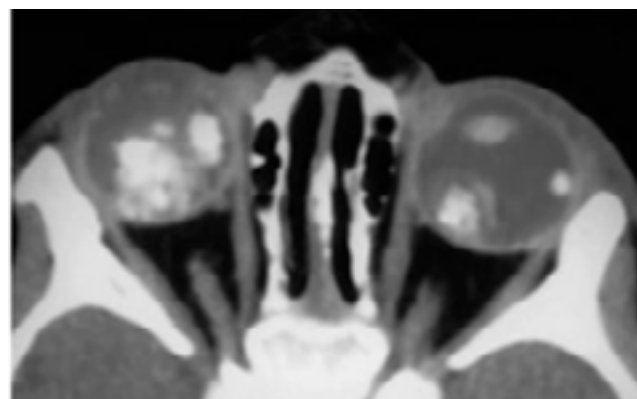
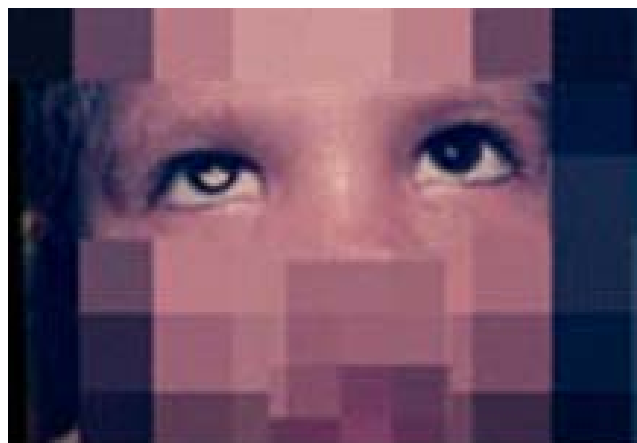
Caso clínico:

Julián de 10 años de edad, es deportista, juega al fútbol 2 veces por semana, y luego de un traumatismo sufrido en el entrenamiento en el miembro inferior derecho, comienza con dolor, que inicialmente cedía con analgésicos comunes. Tras diez días de evolución de dolor el mismo se intensificó y notó la presencia de una tumoración en muslo por encima de la rodilla por lo que consulta por guardia. Se solicita Rx de miembro inferior donde se observa una lesión lítica en epífisis inferior de rodilla derecha, con despegamiento de la cortical a ese nivel.

El dolor musculoesquelético es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, con una frecuencia del 6,2% en mayores de 3 años. Sin embargo, el origen será tumoral en menos del 1% de los casos.

Entre los cánceres más frecuentes que se presentan con dolor óseo y/o articular, encontramos: tumores óseos primarios, neuroblastomas, linfomas Hodgkin y leucemias.

El dolor óseo localizado de origen tumoral suele ser: persistente, asimétrico, progresivo, responde mal a los analgésicos habituales y puede despertar por la noche. En un 60-70% de los casos, se observa una masa palpable adherida



a planos profundos, indurada y de crecimiento rápido y progresivo. Las neoplasias más frecuentes en estos casos son los tumores óseos primarios, como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing.

En el paciente con dolor óseo y/o articular, con sospecha de cáncer, realizaremos una radiografía simple, así como un hemograma completo con frotis de sangre periférica, reactantes de fase aguda, fosfatasa alcalina y LDH en un plazo de 48 horas. Si la radiografía es patológica, se derivará al paciente a un centro especializado en las siguientes 48 horas. Ante la sospecha de leucemia (dos o más citopenias y/o blastos) la derivación será inmediata.

Osteosarcoma:

Se trata del tipo más común de cáncer de

huesos en niños y adolescentes. Afecta predominantemente los huesos largos. Su principal manifestación clínica es el dolor óseo localizado (primer síntoma), tumoración de crecimiento progresivo e impotencia funcional. Al momento del diagnóstico, alrededor de un 20% de los pacientes ya tienen metástasis.

La localización más frecuente es fémur distal (40%) y tibia proximal (20%), comprometiendo mayormente las metáfisis de los huesos largos, pero también puede aparecer en húmero, esqueleto axial, pelvis (8%) y mandíbula. Un 5% son multifocales, es decir, que comprometen más de un hueso al momento del diagnóstico. Suelen ser más agresivos, tiene más incidencia de metástasis pulmonares y peor pronóstico.

Diagnóstico

-Radiografía simple: El aspecto radiológico más clásico es una lesión ósea no uniforme con área de destrucción lítica y esclerosis asociada con destrucción de la cortical y compromiso de partes blandas. La reacción perióstica es en general irregular con espículas radiadas cuyo centro corresponde al centro de la masa tumoral. La masa tumoral avanzada puede producir un triángulo de Codman. Puede aparecer esclerosis, destrucción de la cortical e invasión de partes blandas.

-Gammagrafía con Tc99: permite evaluar osteosarcomas multifocales

-TAC de tórax: de utilidad para evaluar metástasis.

-RMN: nos brinda información sobre el sitio afectado, extensión del tumor compromiso de partes blandas. Es de utilidad para evaluar la estrategia quirúrgica

-Biopsia: debe ser llevada a cabo por un traumatólogo pediatra con experiencia.

El diagnóstico se realiza únicamente por anatomía patológica, por lo que se recomienda que las muestras sean analizadas por anatomopatólogos con experiencia en tumores óseos, para evitar errores diagnósticos.

-Laboratorio: No hay parámetros de laboratorio específicos, pero el aumento de LDH y FAL se relaciona con extensión de la enfermedad.

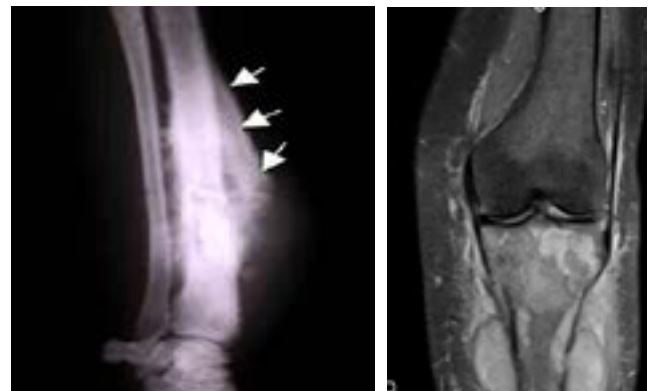
Tratamiento

-El tratamiento se basa principalmente en poliquimioterapia prequirúrgica cuyo objetivo es disminuir el tamaño tumoral para facilitar la cirugía.

-Cirugía: Se lleva a cabo luego de la evaluación por imágenes posterior a la quimioterapia preoperatoria, en este momento el traumatólogo además de resecar la masa tumoral evalúa la posibilidad de colocación de prótesis. El control local de la enfermedad es fundamental, ésta es la razón por la que los osteosarcomas de localización axial tienen peor evolución.

-Quimioterapia postoperatoria para erradicar la enfermedad micrometastásica. La radioterapia en el osteosarcoma no ha mostrado beneficio. En algunos casos se utiliza con fines paliativos. En otros casos, como en osteosarcoma de mandíbula, columna o pelvis, en quienes es difícil lograr la resección completa, o ante la presencia de márgenes positivos, también se puede usar la radioterapia.

-Anatomía Patológica Postquirúrgica: luego de la cirugía, se evalúa la respuesta a la quimioterapia preoperatoria en base al porcentaje de células necróticas dentro de la pieza quirúrgica. La respuesta histológica a la quimioterapia preoperatoria es un factor pronóstico importante.



Sarcoma de Ewing:

Es el segundo tipo más común de cáncer de hueso en niños, pero es muy poco común. Aproximadamente la mitad de todos los tumores del sarcoma de Ewing ocurren en niños y jóvenes de entre 10 y 20 años. Afecta un poco más a varones que a mujeres.

No parece ser hereditario (transmitido por familiares).

Aunque no se ve a menudo, el sarcoma de Ewing puede ocurrir como un segundo cáncer, especialmente en pacientes tratados con radioterapia.

Las características radiológicas son variables. En general se presenta como lesión osteolítica diafisaria que compromete la porción medular

de los huesos tubulares largos cerca de la unión metafisodiafisaria con transición gradual con el hueso normal. Puede haber interrupción de la cortical y reacción perióstica en forma de capa múltiple (catáfila de cebolla) o finamente espiculada. La localización del tumor primario suele ser en fémur (22%) y pelvis (23%) pero también puede presentarse en tibia y peroné, columna, torax (parrilla costal) y húmero. Otras localizaciones menos frecuentes son: cráneo (5%) y partes blandas (menos del 1%).

Dependiendo de su ubicación, dará síntomas precoces o tardíos. La principal manifestación clínica suele ser dolor (intermitente al inicio) y masa palpable. El retraso diagnóstico es muy frecuente, sobretodo en tumores pélvicos o de columna, donde es difícil palpar la masa y el dolor es intermitente. Cuando dan síntomas, éstos pueden ser neurológicos, por compresión medular, vejiga neurogénica, paraplejía, dificultad respiratoria (si se localiza en parrilla costal), etc. Se pueden presentar con fracturas patológicas, pero no es muy frecuente y no tiene implicancia pronóstica. Siempre pueden estar presentes los síntomas sistémicos: pérdida de peso, fiebre, anorexia, generalmente en pacientes con enfermedad metastásica. Alrededor de un 25% de los pacientes presentan metástasis al diagnóstico, siendo más frecuentes en pulmón (50%), seguido de hueso (40%) y medula ósea (MO).

Diagnóstico:

-Radiografía simple: Las características radiológicas son variables. En general se presenta como lesión osteolítica diafisaria que compromete la porción medular de los huesos tubulares largos cerca de la unión metafisodiafisaria con transición gradual con el hueso normal. Puede haber interrupción de la cortical y reacción perióstica en forma de capa múltiple (catáfila de cebolla) o finamente espiculada.

-TAC de tórax: para evaluar posibles metástasis
-Resonancia nuclear magnética con gadolinio (RNM): del sitio primario, que nos dará información sobre extensión del tumor, compromiso de partes blandas.

-PET (tomografía con emisión de positrones): es altamente sugerido en la estadificación inicial, principalmente para evaluar metástasis óseas. Se recomienda realizarlo siempre que sea posible, en aquellos sitios cuyo tratamiento local no es quirúrgico (columna por ejemplo) para

evaluar la respuesta al tratamiento.

-Biopsia: incisional y evaluación por anatomía patológica nos darán el diagnóstico definitivo.

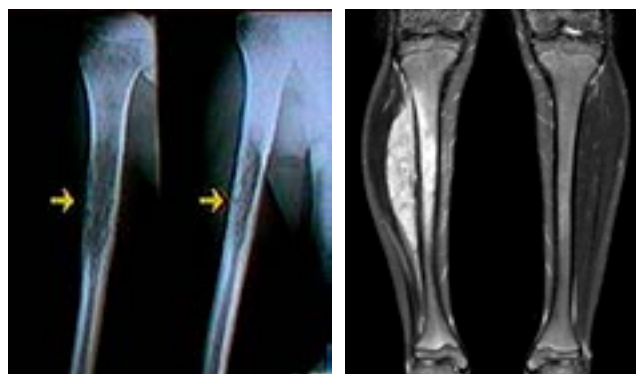
Tratamiento:

-Quimioterapia preoperatoria con el fin de reducir lo más posible el tamaño tumoral y lograr una buena resección quirúrgica.

-Quimioterapia postoperatoria: tiene como objetivo erradicar la enfermedad micrometastásica y reducir la posibilidad de recurrencia de la enfermedad.

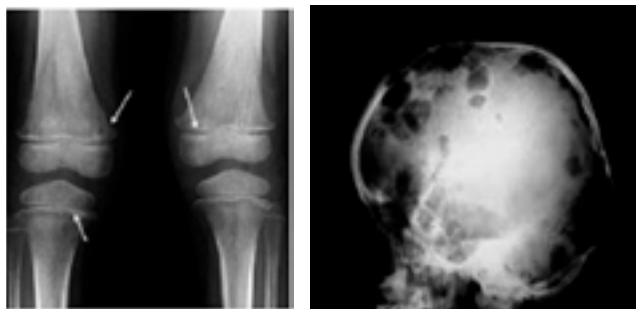
-Radioterapia: El Sarcoma de Ewing es un tumor radiosensible, pero la radioterapia por sí sola no alcanza. Su uso está indicado siempre en caso de márgenes comprometidos.

El uso de radioterapia en forma temprana está indicado sólo en casos de emergencia por compresión medular, o cuando hay progresión tumoral intra tratamiento.



Metástasis óseas:

Las lesiones metastásicas más comunes en el esqueleto de los niños corresponden a leucemia, linfoma o neuroblastoma. La forma de presentación es en general de aspecto apolillado con compromiso a nivel metafisario. Si el compromiso metastásico es generalizado hay tendencia al compromiso bilateral y simétrico.



Osteopenia difusa y bandas radiolúcidas: LLA

Lesiones osteolíticas en calota: Metástasis

Criterio de referencia: algoritmo de tumores óseos, osteosarcoma y sarcoma de Ewing



Bibliografía

- Barrios Marta y Tomás Acha. *Guía de detección temprana; cáncer en niños y adolescentes*. 2015, España AEP-SEHOP.
- Fernández A, Tijeiro Álvarez :Cáp 45: Tumores hepáticos.En: Madero/ Villa: Hematología y oncología pediátricas. 2da ed. Madrid. edit. Ergón. 2005:669-679
- Loza Fariás V, Herrera López M, I Cabello García, PI Navas Alonso. Diagnóstico precoz de cáncer en atención primaria.. *Pediatría Integral* 2016; XX (6): 367 – 379
- Moreno Florencia, Chaplin Agustina. *Criterios de referencias: algoritmo de masa abdominal, neuroblastoma y tumor de Wills. Diagnóstico Oportuno en cáncer infantil. Programa Nacional de Cuidado del Niño y Adolescente con cáncer. P18.*
- Moreno Florencia, Chaplin Agustina. *Criterios de referencias: algoritmo de tumor cerebral. Diagnóstico Oportuno en cáncer infantil. Programa Nacional de Cuidado del Niño y Adolescente con cáncer.P15.*
- Moreno Florencia, Chaplin Agustina. *Criterios de referencias: algoritmo de tumores óseos, osteosarcoma y sarcoma Ewing. Diagnóstico Oportuno en cáncer infantil. Programa Nacional de Cuidado del Niño y Adolescente con cáncer.P21.*
- Moreno Florencia, Chaplin María A. *Criterios de referencias: algoritmos leucemia/linfoma. Diagnóstico Oportuno en cáncer infantil. Programa Nacional de Cuidado del Niño y Adolescente con cáncer, p13.*
- Moreno Florencia. *¿Cuándo sospechar cáncer en el niño??* 2014. INC (Instituto Nacional del Cáncer. Ministerio de Salud de la Nación.

Moreno.Florencia, Chaplin Agustina. *Registro oncopediátrico argentino 2000-2016 6ta ed.*Instituto Nacional del Cáncer.2018

Organización Panamericana de la Salud. *Factores de riesgo de cáncer infantil. OPS p.6-7 .Washington D:C .2014 .*

*Dra. Florencia Moreno

Coordinadora del Programa de Cuidado Integral del Niño con Cáncer (PROCUINCA).
Directora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Instituto Nacional del Cáncer.

**Dra. Emilse Andrea Caballero

Hemato Oncóloga Pediatra.
Médica de planta de Sala de Oncología HIEMI.
Docente cátedra Farmacología y terapéuticas Escuela Superior de Medicina Mar del Plata.

***Dra. María Cecilia Murray

Hemato Oncóloga Pediatra.
Jefa de Sala de Oncología HIEMI.
Docente SANNA Escuela Superior de Medicina Mar del Plata.

INFECCIONES PRE Y PERINATALES

Hospital Integrado Horacio Cestino de Ensenada. Residencia de Clínica Pediátrica



DRA. CAMILA CIGANEK

DRA. SABRINA FLORES

Residentes de 2° año

DRA. MERCEDES ROCHA

DRA. AYELÉN ROJAS RAIES

Residentes de 3° año

DRA. MARIANA ESTEVES

Instructora de Residentes

DRA. MARISA GOLOWCZYC*

DR. ADRIANA LEÓN**

DRA. DANIELA MOYA***

DRA. YÉSICA RAMOS****

DRA. NORA PATRICIA MATTAROLLO

*Revisora******

Sumario

A partir de un caso clínico presentado de toxoplasmosis congénita y considerando el impacto que provocan las infecciones perinatales en el producto de la concepción, el recién nacido y el niño, se describen las que son de detección obligatoria durante la gestación, mediante pruebas serológicas y estudio microbiológico. Las infecciones toxoplásmica, chagásica, sifilítica, por VIH/SIDA, por virus de la hepatitis B y por *Streptococcus agalactiae* que son transmitidas en forma vertical deben ser diagnosticadas tempranamente en el primer nivel de atención. Ello permite efectuar el tratamiento oportuno, así como el seguimiento del binomio madre-hijo. Se hará referencia a la presentación clínica, el diagnóstico y tratamiento y las medidas de prevención.

Presentación del Caso clínico

Juana C. de 35 años cursaba su segundo embarazo, controlado adecuadamente. Grupo y Factor O+. En la semana 20 de gestación presentó fiebre y adenopatías. Se le realizaron análisis de laboratorio en búsqueda de infección y nuevas

serologías, constatándose el viraje serológico para Toxoplasmosis. Se realizó PCR de líquido amniótico, confirmándose el diagnóstico de Toxoplasmosis Congénita. Juana recibió tratamiento con Pirimetamina + Sulfadiazina + ácido folínico y continuó el seguimiento con un especialista en Infectología. Se efectuó ecografía obstétrica-fetal en la semana 24 de gestación, hallándose ventriculomegalia bilateral, calcificaciones cerebrales y hepatoesplenomegalia. Tomás nació a las 34 semanas de edad gestacional, con un peso de 2300 grs, presentando dificultad respiratoria inmediata al nacimiento con requerimiento de ARM por 4 días. Se realizó el correspondiente control oftalmológico confirmando la presencia de coriorretinitis activa bilateral, con afectación macular y vitreitis. Se instauró el tratamiento con Pirimetamina + Sulfadiazina + Ácido folínico y prednisona. Presentó hidrocefalia severa e ictericia que requirió tratamiento bajo luminoterapia (LMT) por 5 días.

Toxoplasmosis congénita

La infección por *Toxoplasma gondii* adquirida por el producto de la concepción durante la ges-

tación, puede producir importantes consecuencias: abortos, mortinatos, morbilidad y secuelas, como coriorretinitis, microftalmía, ceguera, alteraciones en SNC: calcificaciones intracerebrales, microcefalia, hidrocefalia, trastornos neurocognitivos y retraso psicomotor (1).

Agente Causal

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado, que adquiere diferentes estadios: ooquiste, taquizoíto y quiste. Presenta 2 ciclos de reproducción: intestinal o esporogónico (gatos y otros felinos) y extraintestinal o ezquizogónico (en huéspedes intermediarios: mamíferos, como el hombre) y aves, domésticas y silvestres). La fase sexuada ocurre en el intestino de los felinos, con eliminación de millones de ooquistes en materia fecal durante la infección aguda por 7 a 21 días. Los gatos más jóvenes eliminan la mayor cantidad de ooquistes y se convierten en infectantes al ser ingeridos por diferentes mamíferos, incluido el hombre (2).

En el intestino delgado del hombre pasan a taquizoíto y por vía hematógena y/o linfática se diseminan a diferentes órganos. Estas formas se multiplican rápidamente y son responsables tanto de la infección inicial como del daño tisular. También se observan formas más cortas de crecimiento lento, denominadas bradizoítos, que producen quistes en las infecciones crónicas (3). En inmunocomprometidos pueden volver a fase de taquizoítos reactivándose la enfermedad y produciendo formas graves de presentación, como en el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

La patogenicidad de la infección podría estar asociada al genotipo del *T. gondii* involucrado en la infección.

Epidemiología

La toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente en el mundo con alta prevalencia, entre 80-90 % en algunos países. En Argentina la prevalencia de anticuerpos en embarazadas fue de 47,3 % en ciudad autónoma de Buenos Aires; 57,1 % en provincia de Buenos Aires; en provincia de Santa Fe el promedio fue de 42,2% y en 23,8% en Chaco y en Jujuy fue de 39,7%. Tras la infección primaria de la gestante, la tasa de infección fetal estimada varía entre el 1 y el 18% según el

autor (4).

En Sudamérica (Brasil, Colombia, Guyana y Argentina) es frecuente el aislamiento de los genotipos III y atípicos con mayor frecuencia y gravedad, con compromiso ocular en particular (5).

El 4% de niños con infección toxoplásmica congénita presentan posibilidades de morir, tener un daño neurológico permanente o compromiso visual desde los primeros años de vida

La vía de transmisión puede ser horizontal por ingesta de ooquistes o taquizoítos o vertical donde los taquizoítos atraviesan la barrera placentaria y pueden invadir al producto de la concepción. La fuente de adquisición en la gestante es a través de ingesta de carnes crudas o mal cocidas, verduras o frutas mal lavadas y contacto con excrementos de gatos (6).

Riesgo de transmisión materno-fetal

La infección congénita por *Toxoplasma gondii* ocurre cuando la madre cursa la infección aguda durante la gestación y si hubo pasaje placentario.

Puede ocurrir en gestantes seronegativas con seroconversión, por reactivación en embarazadas con inmunocompromiso severo o por reinfección de una gestante previamente inmune con una cepa más virulenta (cepas atípicas) (7).

Las mujeres que presentan serología positiva Ig G para toxoplasmosis previa al embarazo se consideran inmunes y no requieren nuevos tamizajes, en próximos embarazos

La transmisión al embrión o al feto puede ocurrir durante la parasitemia materna en la primoinfección a partir de la 3,5 a 5 semanas de gestación por pasaje de taquizoítos por vía placentaria al feto. La infección aguda en la gestante es asintomática en el 90 % de los casos y un 10 % pueden presentar un síndrome mononucleósico(6).

En la toxoplasmosis crónica, en gestantes inmunodeprimidas, puede ocurrir reactivación focal por ruptura de quistes con pasaje por vía transplacentaria y transmisión fetal.

La patogenicidad de la infección toxoplásmica congénita depende del período de embarazo de la infección materna, de la gravedad de la infección intrauterina, del tratamiento materno y de la virulencia del parásito actuante (5).

El riesgo de infección fetal es inversamente proporcional al daño en el producto de la concepción.

	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
Riesgo	15 %	50 %	75 %
Afectación fetal	60 %	25 %	15 %
Tipo de afectación	Lesiones intracraneales y oculares (generalmente graves)	Lesiones oculares (generalmente no graves)	Excepcional afectación intracraneal, lesiones oculares

Cuadro 1: Porcentaje de riesgo y afectación fetal según edad gestacional (2)

El riesgo de secuelas en el feto, se relaciona de manera inversa con la edad gestacional al momento de la infección. Las infecciones de la primera mitad del embarazo, presentan menor riesgo de transmisión fetal, pero producen una severa afectación en el producto de la concepción, con riesgo de muerte fetal in útero o aborto espontáneo. Las infecciones adquiridas tardíamente en la vida intrauterina generalmente no presentan evidencia clínica al nacimiento.

Por lo cual es imprescindible el tamizaje universal en la gestante, la evaluación al recién nacido en caso de infección aguda durante el embarazo y el seguimiento del niño lo que evaluará el real impacto del problema en la población.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad congénita se manifiesta en la vida intrauterina o después del nacimiento. El recién nacido (RN) puede manifestar distintos escenarios clínicos dependientes del momento en que ocurrió la primoinfección en la gestante (6).

Existen 4 formas de presentación:

- ✓ Infección neonatal: gravemente afectado con infección generalizada, compromiso del SNC y secuelas
- ✓ Infección que se evidencia en los primeros meses de vida: asintomáticos al nacer y aparición de síntomas tardíamente leves o graves.
- ✓ Infección tardía por recaída o secular: como coriorretinitis por reactivación o menos frecuente convulsiones.
- ✓ Infección asintomática: el 90 % de los ca-

sos subclínicos con Ig G persistente. Sin tratamiento existe el riesgo de que desarrollen en los primeros 20 años de vida manifestaciones neurológicas y coriorretinitis (1).

En la infección adquirida anterior a la semana 20 de gestación se presentan manifestaciones como la Tríada de Sabin: hidrocefalia o microcefalia, calcificaciones intracerebrales y coriorretinitis. Otras manifestaciones convulsiones, cataratas, glaucoma, atrofia del nervio óptico, cicatriz macular, microftalmía.

Además hallazgos signo-sintomatológicos de infección generalizada, semejantes a otras infecciones congénitas, como fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia, exantema, neumonitis, meningoencefalitis, diarrea y con presencia de anemia, trombopenia y eosinofilia.

Diagnóstico

El diagnóstico en la gestante de infección toxoplásmica aguda se define por la seroconversión o por el aumento significativo de títulos de Ac IgG (2 determinaciones separadas por 2-3 semanas), aparición de títulos elevados de IgM y presencia de IgG de baja avidéz (< al 20 %).

La IgM es detectable a las 2 semanas de la infección, presenta el pico a las 4-6 semanas y declina a los 6-9 meses, pudiendo persistir positiva más de 1 año, por lo que debe ser complementado con otras técnicas para descartar o confirmar la infección.

Se recomienda utilizar prueba de IgG para toxoplasmosis en la mujer en edad fértil, previa al embarazo, para evaluar su estado inmune.

En la embarazada se recomienda realizar IgG por técnica ELISA o IFI. No se recomienda realizar IHA porque presenta seroconversión tardía.

El diagnóstico de infección fetal se puede realizar por técnica de PCR en líquido amniótico a partir de la semana 18 a 20 de gestación (sensibilidad 70-80 %) en infección aguda confirmada, debiendo realizarse después de transcurridas como mínimo 6 semanas, después de la infección aguda.

El diagnóstico en el RN se hace mediante dosaje de IgM específica (sensibilidad < 50 %), por el mantenimiento de las IgG luego de los 6-12 meses, o por técnicas de PCR en sangre, LCR, orina, muestras oculares y placenta (sensibilidad baja) (1,6).

Evaluación y Tratamiento

La embarazada con primoinfección debe recibir tratamiento hasta el parto. El esquema terapéutico a indicar tiene en cuenta la evaluación clínica, serológica, ultrasonografía, PCR en líquido amniótico y el momento del embarazo que se inicia el tratamiento.

La administración temprana del tratamiento disminuye la transmisión vertical del parásito (2,6).

	Drogas	Forma comercial	Embarazada
Esquema 1	Pirimetamina	1 comp = 25 mg	25 a 50 mg /día, 1 a 2 veces al día.
	Sulfadiazina	1 comp = 500 mg	4 gr /día, 4 veces por día
	Ácido fólico	1 comp = 15 mg	15 mg/día, 3 veces por semana
Esquema 2	Espiramicina	1 comp = 1 gr	3 mg /día, 3 veces por día

Cuadro 2: Tratamiento en la gestante (8)

Desde la sospecha de infección toxoplásmica en la gestante, ante la posibilidad de retraso en la confirmación diagnóstica puede comenzarse el tratamiento con espiramicina (2).

En el primer trimestre y en el último mes del embarazo no se debe utilizar pirimetamina + sulfadiazina.

La evaluación del recién nacido de madre con infección aguda, debe ser clínica, serológica y por métodos complementarios.

Realizar examen físico detallado, diagnóstico por imágenes (ecografía cerebral, TAC), fondo de ojo y serología pareada IgG (madre e hijo) e IgM al recién nacido.

Si la madre recibió tratamiento desde el diagnóstico de la infección y el RN no presenta clínica ni estudios complementarios que demuestren infección, se debe repetir la IgG cada 6 a 8 semanas, hasta la negativización entre los 9 a 10 meses de vida descartando la infección.

En caso de infección toxoplásmica en el RN, con serología IgM e IgE positivas, debe recibir

tratamiento durante el primer año de vida.

Esquema en el RN:

Pirimetamina: Dosis de ataque: a 2 mg/kg/día, vía oral por 2 días. Dosis de mantenimiento: 1 mg/Kg /día durante 2 a 6 meses y luego en días alternos (3 veces por semana).

Sulfadiazina: Dosis: 100 mg/kg/día en 2 dosis vía oral

Ácido fólico; Dosis: 5-10 mg/kg/día, 3 veces por semana, vía oral.

Deben realizarse controles de toxicidad mediante hemogramas.

En caso de procesos inflamatorios activos se agregan corticoides, Prednisona: dosis: 1 mg/kg/día en 2 dosis, hasta mejoría (6).

Se deben realizar al niño controles serológicos, neurológicos, auditivos y oftalmológicos en los primeros años de vida.

Prevención

Las medidas preventivas apuntan a medidas higiénicas en la embarazada seronegativa, relacionadas con la manipulación y cocción de los alimentos, el cuidado de las mascotas (gato) y los trabajos de jardinería.

La prevención secundaria consiste en el diagnóstico temprano mediante la pesquisa en los controles de embarazo, esto nos permite a través del tratamiento oportuno disminuir la incidencia, severidad y secuelas de la infección en el feto y neonato.

La toxoplasmosis congénita se considera una enfermedad prevenible, mediante la educación y el tamizaje prenatal que permite diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Es importante lograr un adecuado control prenatal de la población para lograr el éxito de estas estrategias.

Sífilis congénita

Introducción

La sífilis ha presentado un aumento notable en la última década, en especial en la población de adolescentes y adultos jóvenes, esto se evidencia además en los recién nacidos infectados, de madres con embarazos no adecuadamente controlados, presentando sífilis congénita (SC). El impacto de la transmisión vertical en el recién nacido y el niño provoca morbilidad, complicaciones, daño secuelar y mortalidad (9) (10).

Epidemiología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima aproximadamente 12 millones de casos nuevos por año y una prevalencia de embarazadas con serología positiva entre 0.02% y 4.5% en países desarrollados y 3 a 18% en países en vías de desarrollo (11).

Datos referidos por el Ministerio de Salud de La Nación en el Boletín Integrado de Vigilancia, publicado en febrero de 2018, se notificaron hasta semana 52 de 2017, 850 casos de SC y se confirmaron 485, correspondiendo al 44 % (n:1105) de los casos de SC del país (12).

La tasa de incidencia de SC en provincia de Buenos Aires en el año 2018 fue de 2,41‰ (606 casos SISA) y en 2019 fue de 2,48 ‰ (622 casos SISA) (13).

La iniciativa regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la Meta de Eliminación de la transmisión materno infantil de la Región de las Américas, para el año 2020 del VIH, Sífilis, Enfermedad de Chagas Mazza y hepatitis B perinatal (Metas ETMI plus), para alcanzar una tasa de transmisión materno infantil del VIH a 2% o menos, reducir la incidencia de la sífilis congénita (incluidos los mortinatos) a 0,5 casos o menos por 1.000 nacidos vivos, reducir la prevalencia de HBsAg en los niños de 4 a 6 años de edad a 0,1% o menos y lograr que por lo menos un 90% de los niños con la Enfermedad de Chagas- Mazza se curen y presenten un resultado serológico negativo después del tratamiento(14).

Agente causal

Treponema pallidum, pertenece a la familia Spirochaetaceae, es una espiroqueta alargada, de forma helicoidal, móvil, cuyo único reservorio es el hombre y que se disemina por vía hematogena alcanzando la placenta, comprometiendo órganos y sistemas del producto de la concepción y pudiendo provocar la muerte fetal en etapas precoces de la gestación.

Vía y Riesgo de transmisión

La vía transmisión en el feto es transplacentaria o connatal por contacto directo durante el parto con las lesiones genitales maternas (15).

El riesgo de transmisión de madre a hijo depende del periodo en el cual se desarrolle la infección en el feto, el estadio evolutivo materno y el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento, siendo muy variado el espectro clínico de presentación (16).

El riesgo de transmisión es del 70 al 100% con sífilis primaria o secundaria materna (con el 40 al 50 % entre mortinatos, prematuros o muerte neonatal y el 50 % con sífilis congénita). En sífilis latente temprana el riesgo es aproximadamente del 40 %, (dentro de los cuales el 20-60% son asintomáticos).

En sífilis latente tardía el riesgo de transmisión es del 8 % (con 70% de recién nacidos asintomáticos, el 10% sintomáticos, 10 % mortinatos, 9 % prematuros y el 1% muerte neonatal)

Se debe realizar el estudio anatomopatológico de la placenta a para evaluar la presencia de anomalías placentarias como agrandamiento placentario, vellositis aguda, inmadurez de las vellosidades, fusinitis (17).

Definición

Se considera Sífilis congénita:

- ✓ Todo recién nacido o mortinato cuya madre tuvo sífilis no tratada o que fue inadecuadamente tratada, independientemente de la presencia de signos, síntomas o resultados de laboratorio;
- ✓ Todo recién nacido con evidencia clínica de sífilis congénita
- ✓ Otras manifestaciones frecuentes pero inespecíficas son la hepatoesplenomegalia, ictericia, adenopatías generalizadas, neumonitis, osteocondritis, compromiso del SNC. En estudios complementarios, anemia hemolítica y plaquetopenia.
- ✓ Todo niño menor de 18 meses con pruebas no treponémicas o treponémicas reactivas (en los que no se pueda constatar el adecuado tratamiento de la madre);
- ✓ Todo niño mayor de 18 meses con pruebas treponémicas positivas en los que se hubiese descartado abuso sexual.

También considerar a todo recién nacido, aborto o mortinato cuya madre tuvo sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratada o sin constancia de tratamiento, independientemente de la presencia de signos, síntomas o resultados de laboratorio.

Manifestaciones clínicas

La sífilis congénita se divide en temprana o precoz y tardía según el momento en el cual comienzan los síntomas.

Las manifestaciones clínicas en la Sífilis congénita temprana o precoz aparecen durante los primeros 2 años de vida.

- Linfadenopatía difusa
- Anemia hemolítica, trombocitopenia por secuestro esplénico
- Exantema mucocutáneo, lesiones eritemato-maculopapulares o vesiculobullosas (Pénfigo sifilítico)
- Rinitis sifilítica
- Ragades
- Síndrome nefrótico, HTA hematuria, proteinuria, hipoproteinemia, hipercolesterolemia, hipocomplementemia.
- Gastrointestinal: gastroenteritis, peritonitis, pancreatitis, hepatoesplenomegalia, ictericia, elevación de las enzimas hepáticas.
- Osteoarticular: osteocondritis y periostitis que cursan con dolor, la pseudoparálisis de Parrot, líneas de Wimberger por desmielinización de la metáfisis
- Neumonía
- Corioretinitis, glaucoma
- Hidropesía no inmune
- Masas testiculares.

Los datos de laboratorio pueden presentar anemia, reacción leucemoide (leucocitos $>35.000 \times \text{mm}^3$), trombocitopenia ($<150.000 \times \text{mm}^3$ plaquetas), transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia directa y análisis de orina con proteinuria, hematuria, cilindruria.

En el examen citofisicoquímico del líquido cefalorraquídeo (LCR) se ve aumento de las proteínas ($>150 \text{ mg/dL}$ en el recién nacido a término o $>170 \text{ mg/dL}$ en el recién nacido pretérmino) o conteo de células $>25 \times \text{mm}^3$, a predominio linfocitario (meningitis aséptica) sin otra causa que lo explique o VDRL reactiva en cualquier dilución.

Las manifestaciones de Sífilis congénita tardía son producto de la inflamación granulomatosa crónica. Aparecen después de los 2 años de vida y se evidencian entre los 5 y los 30 años de vida.

- Frente olímpica (protrusiones óseas frontales) (87%)
- Dientes de Hutchinson (63 %), molares en

forma de mora

- Nariz en silla de montar (74%)
- Cicatrices rinitis/ragades sifilítica
- Queratitis intersticial uni o bilateral, coroiditis, retinitis, oclusión vascular, atrofia óptica
- Tibias en sable
- Tabes dorsal y paresia juvenil
- Triada de Hutchinson: sordera, dientes de Hutchinson y queratitis intersticial (patognomónica)
- Fenómeno de Raynaud
- Lesiones en SNC: Retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, sordera (11).

Diagnóstico

El diagnóstico de sífilis congénita requiere de la revisión de las serologías maternas, el tratamiento de la gestante, la presencia de manifestaciones clínicas y los resultados recabados de los estudios realizados al RN (17,18).

El diagnóstico prenatal puede realizarse a través del algoritmo tradicional para la detección serológica de sífilis en la embarazada, con VDRL y confirmación con prueba treponémica (PT).

Las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) miden la presencia de anticuerpos no específicos para la enfermedad, se utilizan para el tamizaje (presentan alta sensibilidad, baja especificidad) pudiendo dar falsos positivos y las pruebas treponémicas (TP-PA, FT-abs, ELISA, pruebas rápidas) detectan anticuerpos específicos para sífilis, por lo que identifican la exposición a la enfermedad.

En la actualidad se plantea el algoritmo reverso para el diagnóstico de sífilis materna, en los centros de atención primaria, realizando test rápidos que detecta en forma cualitativa anticuerpos contra el *Treponema pallidum* en suero, plasma y sangre entera. La técnica utilizada es por ensayo inmunocromatográfico, obteniendo resultado en 15-20 minutos y con mínimos requerimientos de equipamiento (9).

Se debe testear en los tres trimestres de embarazo, para realizar el diagnóstico temprano y en los casos positivos realizar tratamiento adecuado a la gestante y a la/s pareja/s sexual/es.

En el diagnóstico del recién nacido sólo se utilizarán pruebas no treponémicas (V.D.R.L), detecta anticuerpos anticardiolipinas, siempre debe solicitarse pruebas cuantitativas.

Las pruebas treponémicas en lactantes < 15

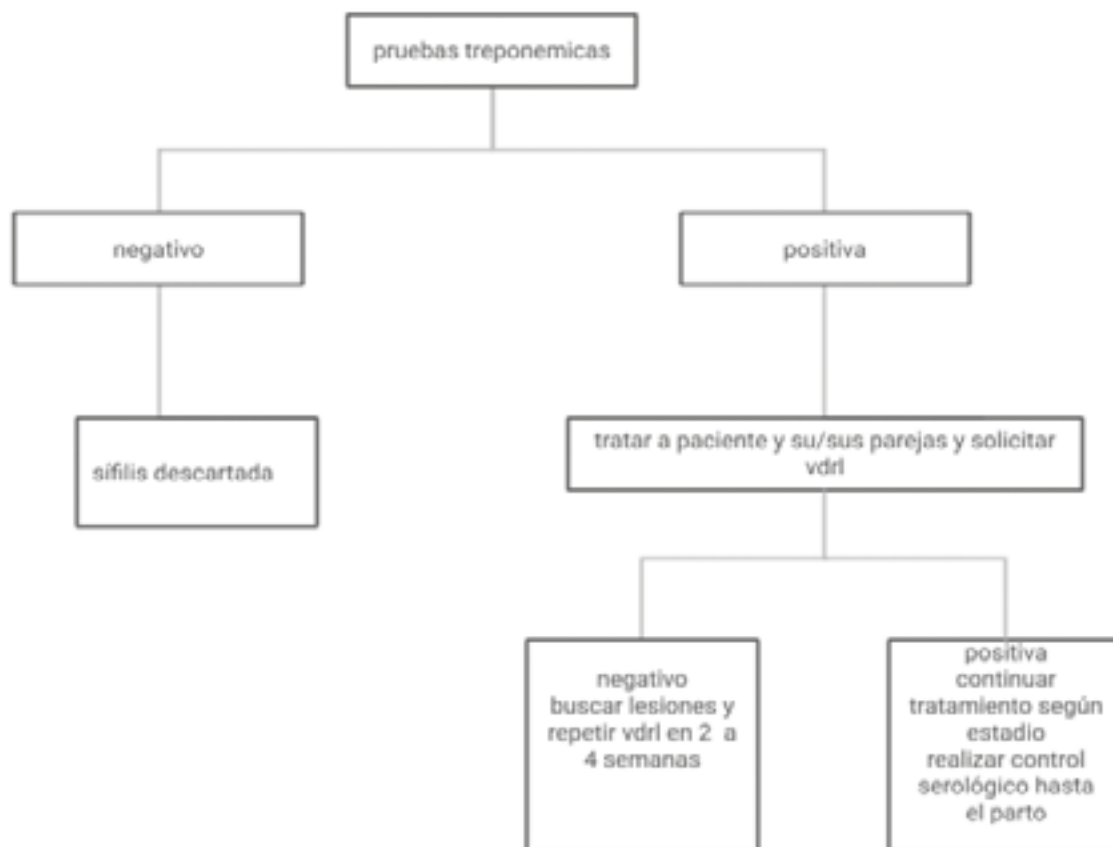


Gráfico 1: Algoritmo de diagnóstico y tratamiento con utilización de Test Rápidos para *Treponemapallidum*: Adaptado y modificado (9)

meses nacidos de madres infectadas, no se recomiendan debido al pasaje transplacentario pasivo de la IgG materna.

No debe utilizarse sangre del cordón para pruebas serológicas en el recién nacido, por pasaje pasivo materno, ni en la madre debido a falsos negativos (18).

La evaluación del RN con manifestaciones clínicas de sífilis congénita requiere estudio serológico (VDRL cuantitativa), laboratorio general (recuento de blancos, recuento de plaquetas, hepatograma y función renal), Rx de tórax, ecografía cerebral, fondo de ojo, evaluación auditiva. Examen citoquímico y VDRL en LCR y Rx de Huesos largos (de acuerdo a escenario clínico).

Tratamiento

Para realizar el tratamiento al RN, se debe tener en cuenta el tratamiento recibido por la madre. Se interpreta como madre adecuadamente tratada quien haya recibido:

- Tratamiento antibiótico con penicilina
- La última dosis de penicilina antes del último

mes del parto

- Tratamiento adecuado para su estadio clínico evolutivo (12).

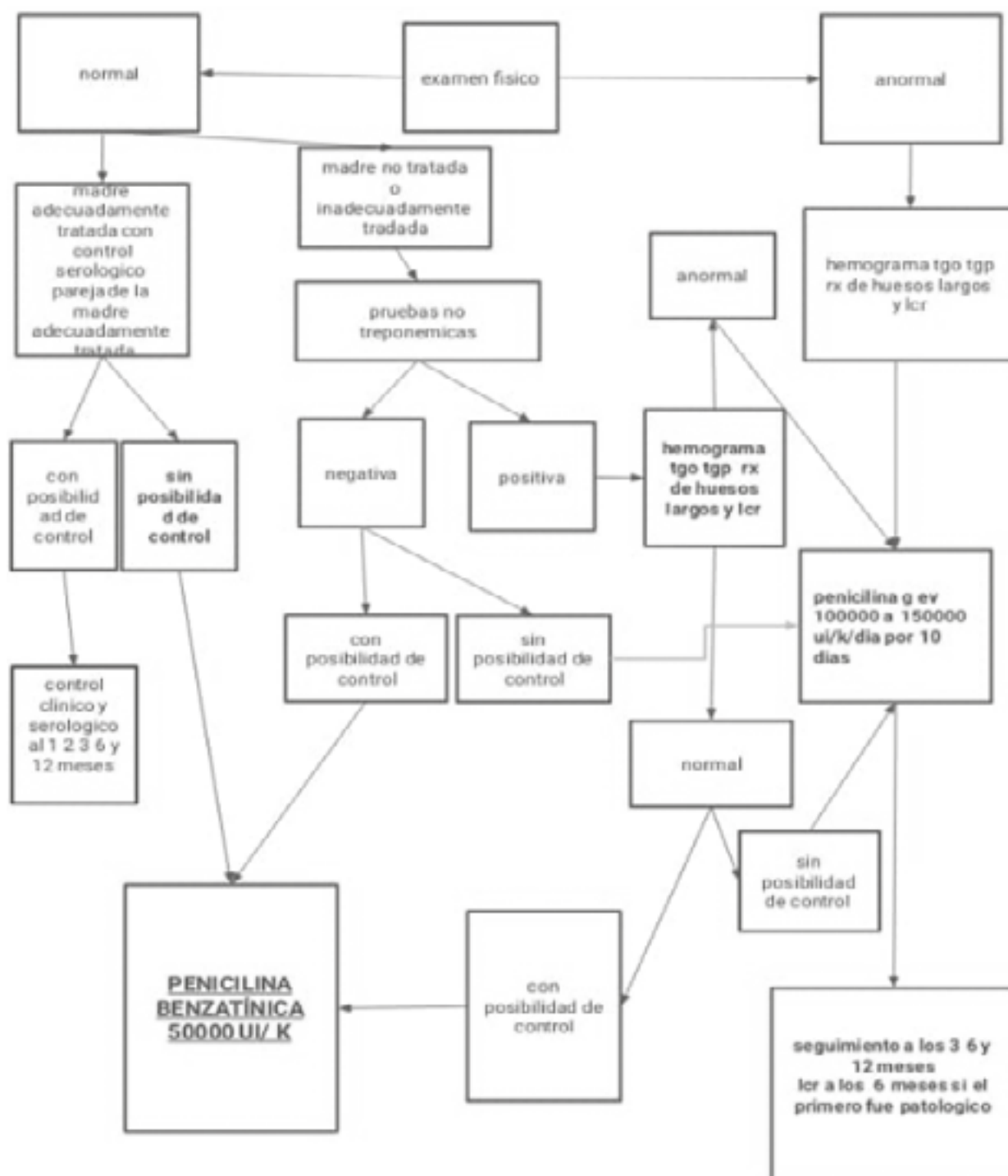
- Se efectuó control con VDRL cuantitativa hasta el parto y durante el seguimiento presenta el descenso esperado.

- En pacientes alérgicos a penicilina, no hay alternativas demostradas, por lo que se sugiere realizar desensibilización.

Tratamiento en la embarazada según estadio clínico

- Sífilis temprana (menor o igual a 1 año de infección, incluye la sífilis primaria, secundaria y latente temprana): administrar 2.400.000 UI de penicilina benzatínica Intramuscular (IM) dosis única.
- Sífilis tardía (sífilis latente mayor a 1 año de duración desde la infección): administrar 2.400.000 UI de penicilina benzatínica IM, una dosis semanal por 3 semanas.
- Sífilis de duración desconocida administrar 2.400.000 UI de penicilina benzatínica IM, una dosis semanal por 3 semanas.

Gráfico 2: Algoritmo de Seguimiento de Recién nacidos hijos de madres PNT (+)(20)



Tratamiento sífilis congénita precoz

- Penicilina G Sódica 50.000 U/kg/dosis IV cada 12 horas (RN ≤ 1 semana de vida) y cada 8 horas (RN > 1 semana de vida)
- En niños mayores de > de 1 mes de vida se recomienda: Penicilina G Sódica 50.000 U/kg/dosis IV cada 4- 6 horas. Duración del tratamiento: 10 días
- Si el niño está asintomático, el LCR es normal y la VDRL en LCR es negativa se puede

de tratar con penicilina benzatínica 3 dosis de 50.000 U/kg IM con intervalo semanal (19).

Seguimiento:

A todo niño con diagnóstico de sífilis congénita tratado, se le debe realizar un correcto seguimiento serológico con VDRL cuantitativa cada 2-3 meses, hasta que el resultado resulte negativo.

Si durante el seguimiento serológico con VDRL se presentan títulos aumentados 4 veces, o se mantienen estables a los 12-18 meses de vida, se requiere nueva evaluación y repetición de tratamiento con penicilina G sódica 50.000U/kg endovenosa, durante 10 días

Chagas congénito

Introducción

La enfermedad de Chagas-Mazza es la zoonosis parasitaria causada por el protozoo flagelado *Trypanosoma cruzi*, que es transmitido por un insecto hematófago que difiere según el área geográfica. En Argentina se conoce como vinchuca o chinche gaucha, al triatoma infestans, vector responsable del ciclo domiciliario.

El Chagas congénito es la forma aguda más frecuente de presentación y la que genera más nuevos casos en la Argentina en áreas donde no hay transmisión vectorial.

Epidemiología

Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas, la mayoría en América Latina. La población de América Latina expuesta al riesgo de infección por *Trypanosoma cruzi* supera los 108 millones y los nuevos casos agudos vectoriales por año se estimaron en 41.200 personas (21). En la embarazada, el parásito puede hallarse en la sangre periférica tanto en la fase aguda como crónica y puede transmitir la infección en cualquiera de estos dos periodos y en embarazos sucesivos. La prevalencia en la embarazada es del 4-32% en la Argentina dependiendo de área geográfica. Debe evaluarse otro indicador como el número de Chagas Neonatal, ya que, controlada la vía vectorial y transfusional, se convierte en la principal causa de transmisión de la enfermedad (22).

El 1 al 7 % de los hijos de madres chagásicas crónicas, presentarán infección congénita.

La transmisión vertical, madre a hijo, depende de diferentes factores inherentes al parásito, estado inmune de la madre y factores placentarios. La infección puede transmitirse en cualquier estadio de la infección materna, aguda o crónica, dado que ocurren parasitemias intermitentes y bajas en esta última.

Agente causal

El *Trypanosoma cruzi*, es un parásito hemotísular, protozoo, flagelado con kinetoplasto, perteneciente a la familia Trypanosomatidae. Presenta tres formas morfológicas tripomastigote (se encuentra en sangre en el hombre e intestino posterior del triatoma), amastigote (forma tisular en el hombre) y epimastigote (solo en el intestino medio del triatoma) (3).

Manifestaciones Clínicas

La forma congénita de la enfermedad de Chagas es en el 60 al 90% de los casos asintomática. En las formas sintomáticas pueden producirse abortos o muerte fetal. Los signos clínicos más frecuentes son: prematuridad, bajo peso al nacer, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, anemia, fiebre, hipotonía muscular, edemas, neumonitis, hidrops fetal, sepsis, microcefalia y miocarditis (8).

Diagnóstico en la embarazada

Para un adecuado diagnóstico es imprescindible la pesquisa serológica por dos técnicas inmunológicas a partir del primer control obstétrico. En la gestante de las dos pruebas serológicas reactivas, una debe corresponder a ELISA o IFI.

En Argentina la detección con pruebas diagnósticas en la gestante es obligatoria por Ley 26.281/07. Además, la ley de pesquisa neonatal 26.279/07 incluye el estudio y seguimiento para pesquisa de Chagas durante el primer año de vida, a todo niño nacido de madre con diagnóstico de enfermedad de Chagas.

Diagnóstico parasitológico en el Recién nacido

- ✓ Métodos directos (detección de parasitemia): realizar en los primeros días de vida, muestras seriadas
- ✓ Gota fresca: se emplea solo una gota de sangre entre portaobjeto y cubreobjeto. Requiere una observación prolongada al microscopio por parte del operador (45 minutos).
- ✓ Gota gruesa.
- ✓ Strout.
- ✓ Técnica de microhematocrito: es la más adecuada para su uso en pediatría. Se toman 6 capilares de hematocritos de sangre heparinizada y se centrifugan a 3.000rpm durante 40 segundos; se extiende la capa

de glóbulos blancos y se observa durante 30 minutos, en un microscopio (400x), en búsqueda del parásito. Esta técnica requiere entrenamiento del operador, utiliza pequeños volúmenes de sangre (0,5 ml).

Estas técnicas presentan una sensibilidad variada entre el 50 al 90 %, dado que son operador dependiente.

Reacción de la cadena de la polimerasa (PCR), disponible actualmente para inmunocomprometidos y seguimiento de pacientes tratados.

A partir de los 9-10 meses de vida se deben realizar estudios serológicos, por 2 métodos diferentes, los más utilizados son HAI, ELISA e IFI, para confirmar la infección chagásica en el niño.

Si se confirma el diagnóstico de Chagas congénito realizar estudios complementarios: Hemograma y recuento de plaquetas, hepatograma. Rx tórax, evaluación cardiológica y gastroenterológica. Evaluación visual y auditiva.

Tratamiento

Comenzar tratamiento en todo niño con infección comprobada, es decir recién nacido con parasitemia positiva y lactante $\geq$ a 10 meses de vida con pruebas serológicas reactivas. No se debe indicar en la embarazada por riesgo tera-

togénico (23,24).

Las drogas que han demostrado eficacia son Benznidazol y Nifurtimox.

Benznidazol: se utiliza en una dosis de 5-7 mg/kg/día en 2 dosis por 30-60 días. Los efectos adversos más frecuentes: erupciones cutáneas (generalmente leves), gastrointestinales, neuropatía periférica (dosis dependiente, reversible). Menos frecuente aplasia medular.

Nifurtimox: dosis: 10-12 mg/kg/día en 2-3 dosis. Iniciar a 5 mg/kg/día con valoración hematológica semanal aumentando paulatinamente hasta alcanzar dosis terapéuticas. En general, la medicación es bien tolerada en los niños. Efectos adversos: anorexia y pérdida de peso, irritabilidad, vómitos, leucopenia y plaquetopenia.

Duración del tratamiento: 60 días

La parasitemia suele negativizar a las 2-3 semanas de iniciado el tratamiento, si se mantiene positivo evaluar baja dosis o vómitos.

Controles durante el tratamiento: Examen Hematológico y función renal, a los 20 días de comenzado el mismo.

Realizar control serológico al final del tratamiento y cada 3 meses, hasta obtener 2 controles sucesivos negativos con un intervalo de 6 meses.

El criterio actual de curación es la negativización de la serología en los controles post-trata-

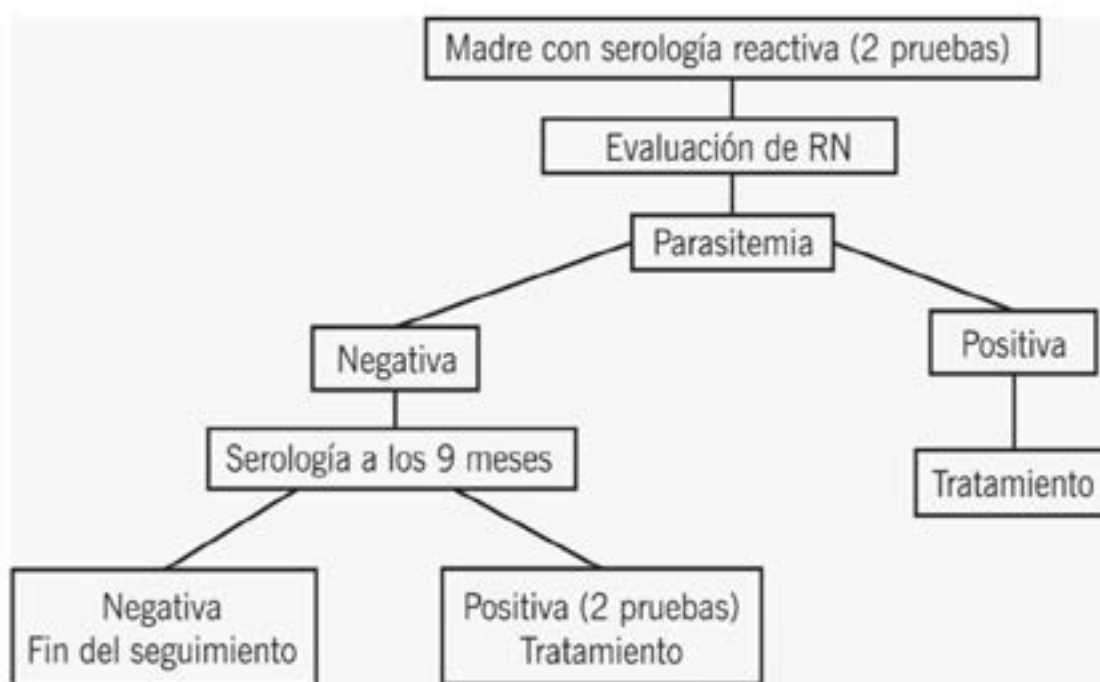


Gráfico 3- Algoritmo de Evaluación del niño, hijo de madre con Chagas crónico (8)

miento. Si no se logra la negativización, se continúa con controles serológicos anuales hasta negativizar.

La OMS recomienda evaluación y tratamiento en la madre cuando suspenda la lactancia y se descarte nuevo embarazo.

Hepatitis B perinatal

Introducción

La hepatitis B constituye un importante problema en salud pública en todo el mundo. La transmisión perinatal puede ocasionar en el recién nacido mayor riesgo de formas crónicas, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, de no mediar estrategias adecuadas, el 90 % de estos niños evolucionarán a la cronicidad (25).

El riesgo de infección crónica es inversamente proporcional a la edad en que ocurrió la infección: en el neonato es de un 90%, entre la edad de 1 a 5 años es de un 25 a 50% y en adultos es de < 5%.

Epidemiología

Más de 350 millones de personas padecen infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) en todo el mundo. En los países en vías de desarrollo hasta un 15% de la población puede infectarse al nacer o durante la infancia (3).

Se estima que el 50 % de portadores crónicos adquirió la infección por transmisión vertical, persistiendo la transmisión en la población de la infección (26).

En Argentina se considera una región geográfica de endemicidad baja, es decir con menos del 2 % de HBsAg (+) donde la enfermedad se adquiere predominantemente en la edad adulta.

El reservorio es humano, presentando infección aguda, crónica y estado de portador.

La transmisión vertical puede ser:

a) Vía Intraútero (< 5 %) , se relaciona con pasaje demostrado placentario de HBe Ag, estructura viral, mutaciones, indemnidad de placenta, carga viral e inmunidad materna, susceptibilidad del producto por otras noxas;

b) Vía Intraparto (95%) siendo la más frecuente por la exposición del recién nacido a sangre y fluidos biológicos en el momento del pasaje por el canal del parto y

c) Transmisión puerperal, por contacto con sangre, fluidos o leche materna con VHB, su incidencia es baja (27).

Agente etiológico

El virus de la hepatitis B, es un virus hepatotrópo, perteneciente a la familia Hepadnaviridae . Es un virus envuelto, ADN bicatenario, que presenta antígenos de superficie (HBsAg), del núcleo (HBc Ag) y (HBe Ag). Estos componentes antigénicos inducen la formación de anticuerpos según la etapa de la infección.

La principal fuente de virus infecciosos es la sangre, aunque el VHB se puede encontrar en el semen, la saliva, la leche, las secreciones vaginales, menstruales y el líquido amniótico (3).

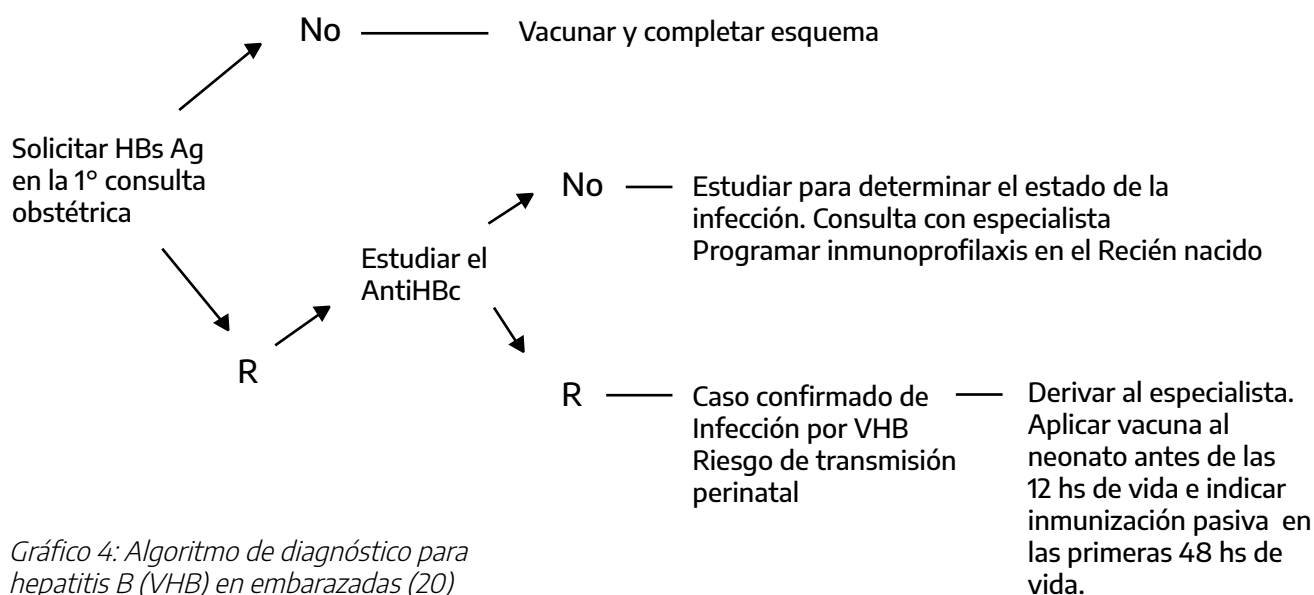


Gráfico 4: Algoritmo de diagnóstico para hepatitis B (VHB) en embarazadas (20)

Estudios serológicos en la embarazada

La detección temprana de la infección por VHB en la mujer embarazada y/o su pareja/s sexual/es y el adecuado y oportuno tratamiento son estrategias fundamentales para la prevención de la transmisión perinatal (gráfico 4).

Si la embarazada es HBs Ag + evaluar otras ITS y a su pareja/s sexual/es. Se recomienda el uso de preservativo hasta que su pareja se encuentre inmunizada.

Si la embarazada es HBs Ag (-) se le recomienda vacunación antihepatitis B a ella y a su/s pareja/s, si no tienen constancia de aplicación previa.

Manejo del hijo de madre HbsAg+

Inmuno profilaxis en el Recién nacido (RN)

La transmisión vertical se reduce significativamente entre un 85 a 95%, cuando se administra IGHB y vacuna. Se indica profilaxis activa-pasiva al RN.

El RN debe recibir vacuna para HBV monovalente antes del 12 Hs de nacido. En los recién nacidos $\leq$ de 6 semanas solo se puede aplicar vacuna de hepatitis B mono dosis.

El esquema debe continuar con la quintuple (pentavalente), según Calendario Nacional de Vacunación. Debe recibir en total 4 dosis de vacuna para VHB: RN, 2, 4, 6 meses de vida.

La gammaglobulina específica IGHB: Dosis 0,5 ml, se indica al nacer (pudiéndose aplicar hasta 7 días posteriores al nacimiento). La eficacia de la IGHB disminuye cuanto mayor es el tiempo transcurrido entre la exposición y la administración de la misma. La de aplicación es vía intramuscular (IM) en sitios distintos de la vacuna.

Si la madre es HBS Ag + realizar control evolutivo al recién nacido: solicitar HBs Ag y Anti HBs de 1 a 2 meses de completado el esquema de vacunación (en lactantes esperar a los 9 meses de vida). Si el HBs Ag es + repetir a los 6 meses para evaluar estado de portador y derivar al especialista.

El RN puede recibir lactancia materna si recibió inmunoprofilaxis.

VIH-SIDA

Introducción

La adquisición de la infección perinatal por el

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de madre a hijo, ha disminuido progresivamente en los últimos años debido al control obstétrico en el primer nivel de atención obligatorio para la detección temprana serológica en los tres trimestres de gestación; el manejo de la madre que convive con VIH, desde etapas tempranas, para lograr una supresión viral durante el todo el embarazo y el parto (que constituye el principal factor para prevenir la transmisión perinatal), determinado la modalidad del parto y la implementación del componente neonatal y supresión de la lactancia(28,29) .

Epidemiología

En el mundo 37,9 millones de personas viven con VIH-SIDA, desde el inicio de la epidemia hasta diciembre de 2018 (OMS 15 de noviembre 2019), el Ministerio de Salud de la Nación recibió 10.264 notificaciones, de las cuales 5.397 (53%) pertenecían al grupo de 0 a 14 y 4.867 (47%) al grupo de 15 a 19. El 88% de los niños y niñas diagnosticados entre 2005 y 2014 se infectaron por transmisión perinatal (30).

Agente causal

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus (RNA) que actúa infectando a los linfocitos T con receptores CD4 del sistema inmune, ocasionando progresivamente, la disminución de los mismos y desarrollando evolución a Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), de no mediar diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. El único reservorio actualmente conocido es el hombre.

Manifestaciones clínicas

La infección por VIH en pediatría presenta un amplio espectro clínico, que podría describirse, según su evolución como bimodal.

Evolución precoz y severa, se produce un rápido deterioro de la inmunidad, con aparición de manifestaciones clínicas entre los 6 y 8 meses de vida, como infecciones bacterianas recurrentes, infecciones oportunistas, microcefalia, encefalitis progresiva, hipertensión, espasticidad, retraso madurativo. La sobrevivencia a los 5 años es menor al 3%.

La forma lentamente progresiva es la más común, las manifestaciones aparecen tardíamente

entre los 6 y 8 años de edad, y son infecciones frecuentes, neumonía intersticial linfoidea, linfadenopatías, hipertrofia parotídea e infecciones bacterianas. No presenta compromiso neurológico y el rendimiento escolar es normal (31).

Diagnóstico

El diagnóstico oportuno de la infección por VIH en niños/as es una prioridad de salud pública. El estudio de niños/as con terapia antirretroviral (TARV) precoz demostró que a las 32 semanas de seguimiento, el 96% de los niños/as que iniciaban el TARV antes de las 12 semanas presentaban mejor sobrevida. El inicio temprano del tratamiento en lactantes antes de los 3 meses de vida reduce la mortalidad temprana en un 75%.

Se utilizan para arribar al diagnóstico métodos virológicos directos, a través de la detección de ADN proviral o de mediante la carga viral plasmática (CV). En Argentina se utiliza la CV, que presenta una especificidad del 100%. De esta forma se esto mejoró la accesibilidad y la sensibilidad en el diagnóstico temprano, permitiendo el inicio precoz del tratamiento en los niños positivos. Las pruebas virológicas realizadas en las primeras 48-72 hs de vida del niño/a permiten identificar una infección intrauterina, pueden ser negativos en una infección producida durante los últimos meses del embarazo y el parto. El valor predictivo negativo de este marcador es del 100% a los 6 meses de vida (32).

Algoritmo y criterio diagnóstico:

- ✓ Niño expuesto: RN de una mujer gestante con VIH, a quien todavía no se le ha completado el diagnóstico.
- ✓ Infección confirmada: dos pruebas virológicas positivas para VIH en dos muestras consecutivas, independientemente de la edad.
- ✓ Infección descartada (virologicamente) al menos dos determinaciones virológicas para VIH negativas. Una de ellas posterior a la semana 16 de vida o posterior, en el contexto de: Niños no amamantados sin cuadro clínico relacionado con infección por VIH.
- ✓ Infección excluida: una determinación serológica negativa en niños mayores a 12-18 meses.

Un solo resultado negativo no excluye la infec-

PRECOZ (15-20%)	LENTAMENTE PROGRESIVA (75-80%)
Sintomatología entre 4-8 meses de vida	Manifestaciones SIDA a los 6-8 años de edad
Neumonías por P. jirocii, encefalopatías, retardo del crecimiento, hepatoesplenomegalia, diarreas	Neumonía intersticial linfoidea, linfadenopatías, hipertrofia parotídea e infecciones bacterianas reiteradas
Lenta incubación	Incubación prolongada
Sobrevida a los 5 años < 3 %	Sobrevida prolongada a los 5 años

Cuadro 3-Descripción cuadro clínico, evolución bimodal (31) (32)

ción. Se debe realizar otra prueba virológica a los:

- 14-21 días de vida
- 6 semanas de vida (2 semanas después de terminada la profilaxis)
- 12 semanas de vida (30).

Profilaxis de la transmisión perinatal

La transmisión perinatal puede suceder en 3 momentos:

- 1) Intraútero, a través de la placenta, riesgo de 25 al 40%
- 2) Transmisión intraparto riesgo entre el 60 y el 75%
- 3) Lactancia materna riesgo de 16%.

Si no se realiza intervención preventiva, el porcentaje de infección es entre el 15 y el 35%, mientras que con intervención adecuada puede disminuir al 2%. Los niveles plasmáticos de ARN del VIH en la madre se correlacionan con el riesgo de transmisión, por lo que las posibilidades son bajas cuando la carga viral no es detectable. Se aconseja la realización de cesárea en todas las embarazadas con carga viral plasmática cercana al parto mayor a 1.000 copias/ml. (35) Se recomienda la realización de un control precoz del VIH ya que reduce en un 50% el riesgo in-

fección perinatal; se puede realizar un parto de bajo riesgo en las embarazadas con tratamiento con TARV de alta eficacia y confirmación de CV plasmática menor 1000 copias/ml, lo más cercano al momento del parto a partir de la semana 34 de gestación. La adquisición asociada a la lactancia en mujeres con infección por VIH es de aproximadamente el 14%. La detección precoz de la infección materna es clave en la prevención de la transmisión, por lo que es necesario no perder oportunidades en el diagnóstico. Es indispensable que el/la obstetra y el/la pediatra generen una fluida comunicación para asegurar una profilaxis adecuada y precoz en el neonato. Se debe ofrecer el test diagnóstico de VIH a las mujeres en edad fértil y a sus parejas e indicarlo a las embarazadas en los tres trimestres del embarazo; brindar asesoramiento adecuado y tomar medidas de prevención (30, 31, 32).

Antirretrovirales intraparto:

- Iniciar Zidovudina (AZT) endovenosa con el trabajo de parto o 2 horas antes de la cesárea. Dosis de carga: 2 mg/kg diluida en dextrosa 5%, infundir en una hora. Dosis de mantenimiento: 1 mg/kg/hora hasta el parto o cesárea.
- Todos los neonatos hijos de madre con VIH deben recibir AZT jarabe 4mg/kg/dosis cada 12 horas idealmente comenzando dentro de las 6 horas de vida y no más tarde de las 72hs, durante 4 a 6 semanas.
- Si la madre no ha recibido TARV durante el embarazo, el neonato deberá recibir: AZT jarabe a 4 mg/kg/dosis cada 12 horas entre las 6 y 12 horas de vida por 6 semanas + Lamivudina (3TC) 2 mg/kg/dosis cada 12 horas durante 7 días + una dosis NVP al nacimiento, a las 48 y 96 horas de la segunda dosis. (30, 32, 33).

Situaciones especiales:

- Neonatos de término en los que se contraindica la vía oral, utilizar AZT endovenosa 1,5 mg/kg/dosis cada 6 horas hasta que pueda continuar con la opción oral.
- En prematuros $\geq$ 30 semanas de gestación: AZT endovenosa 1,5 mg/kg/dosis cada 12 horas o AZT oral 2 mg/kg/dosis cada 12 horas. Una vez cumplidas las 2 semanas de vida se administra cada 8 horas.
- En prematuros $<$ 30 semanas de gesta-

ción: AZT endovenosa 1,5 mg/kg/dosis cada 12 horas o AZT oral 2 mg/kg/dosis cada 12 horas. Una vez cumplidas las 4 semanas de vida se administra cada 8 horas.

- Lamivudina (3TC) recién nacido: 2 mg/kg/dosis cada 12 horas, durante una semana.
- Nevirapina (NVP) recién nacido: entre 1500 y 2000 g: 8 mg; y >2000 : g, 12 mg a las 48-72 horas del nacimiento.

La lactancia materna está contraindicada en las mujeres con VIH ya que es una vía de transmisión del virus. Dar leche maternizada de inicio, a todo recién nacido de madre con VIH e inhibidores de la lactancia a la madre (30).

Infección perinatal por *Streptococcus agalactiae* o estreptococo del grupo B (SGB)

Introducción

Streptococcus agalactiae fue aislado por primera vez en el año 1.935 de un caso de Sepsis puerperal. En la década del '70 provocó alta letalidad (50 %) en recién nacidos que presentaron Sepsis neonatal temprana. En el año 1.996 el Center Diseases Control de E.E.U.U. (CDC) realiza el primer consenso sobre la prevención de la enfermedad invasiva estreptocócica, juntamente con la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomendando la administración de profilaxis antibiótica intraparto, basadas en factores riesgo en el embarazo (34).

En el año 2002 el CDC determina la detección universal prenatal materna de la colonización por SGB, en el tracto genitourinario y gastrointestinal. Esta medida en conjunto con la administración de la profilaxis antibiótica intraparto en las embarazadas colonizadas resultó un 50 % más eficaz para la prevención de la enfermedad invasiva neonatal temprana estreptocócica, que la basada solo en factores de riesgo.

Epidemiología

La incidencia de la Enfermedad invasiva neonatal temprana por SGB presentó una reducción de 1,8 casos / 1.000 nacidos vivos en 1990 a 0,23 casos/ 1000 nacidos vivos en el año 2015. En la forma de presentación tardía la tasa de incidencia se mantuvo estable en 0,31 casos/ 1000 nacidos vivos (período 2006- 2015).

A nivel mundial se estiman 200.000 casos de Enfermedad invasiva neonatal temprana, atri-

buyéndose por ésta causa 150.000 muertes fetales y neonatales (mortinatos, enfermedad temprana y tardía), con mayor número de casos en África, constituyendo un problema de salud pública (35).

Agente causal

Streptococcus agalactiae son cocos grampositivos, de crecimiento rápido, con factores de virulencia que facilitan la forma de enfermedad invasiva, como los polisacáridos capsulares que definen 10 serotipos (Ia, Ib, II-IX), siendo los que se asocian con mayor frecuencia a Infección neonatal de comienzo temprano los serotipos Ia (35-40%), III (30%) y V (15%). Mientras que el serotipo III se aísla en la mayoría de los casos de Infección de comienzo tardío (3).

Vía y Riesgo de transmisión

El principal factor de riesgo para la Infección temprana por SGB es la colonización materna en el tracto genitourinario y gastrointestinal (10 a 30 %). Estudios recientes estiman a nivel mundial un 18 % de colonización vaginal y/o rectal en mujeres embarazadas, con variación regional (11 al 35%).

Otros factores que aumentan el riesgo de sepsis neonatal temprana son, la edad materna temprana, raza afroamericana, rotura prematura de membranas (más de 18 Hs), fiebre intraparto, parto prematuro, corioamnionitis, bacteriuria materna durante la gestación o el antecedente de hijo previo con enfermedad por SGB.

La transmisión ocurre durante el trabajo de parto o después de la ruptura de membranas, por colonización ascendente al útero, con la consiguiente colonización del feto, infección invasiva y/o aspiración fetal del líquido amniótico infectado.

Tamizaje Universal en la gestante y profilaxis antibiótica intraparto

En Argentina la detección de la colonización por SGB en la gestante es obligatorio por la Ley Nacional 26.369/2008.

Para la detección de la colonización por SGB se debe realizar la toma de muestra de exudado vaginal y rectal, en la semana 36-37 de gestación (según últimas recomendaciones del CDC 2019). Se realiza por medios de cultivos tradi-

cionales, enriquecidos y/o a través de métodos de biología molecular como la amplificación de ácidos nucleicos.

La recomendación actual para profilaxis intraparto consiste en un protocolo basado en factores de riesgo y tamizaje universal.

La profilaxis antibiótica intraparto (PAI) se recomienda con cultivo vaginal y/o rectal positivo, realizado entre las 35-37 semanas de gestación, antecedente de hijo previo con enfermedad invasiva por SGB, bacteriuria por SGB en cualquier trimestre del embarazo actual (> a 10.000 U formadoras de colonias) o resultado desconocido (asociado a edad gestacional < a 37 semanas, rotura prematura de membranas de más de 18 Hs o fiebre intraparto) (36).

En corioamnionitis instaurar tratamiento antibiótico de amplio espectro.

De elección	Penicilina sódica 5 millones UI de carga y continuar 2.5 a 3 millones cada 4 hs, EV hasta el parto
Alternativo	Ampicilina 2 EV de carga, continuar con 1 gr cada 4 hs hasta el parto
Alergia a β lactámicos con riesgo de anafilaxia y sensible por antibiograma	Clindamicina 900 mg EV cada 8 hs hasta el parto
Alergia a β lactámicos con riesgo de anafilaxia resistente a clindamicina	Vancomicina 1 gr EV cada 12 hs, hasta el parto

*Cuadro 4-Esquemas recomendados en profilaxis antibiótica intraparto (36). *Adaptado y modificado. En: Guía de profilaxis intraparto para Streptococo grupo B.2017*

Cualquiera de estas alternativas debe ser administrada por lo menos 4 hs previas al parto para alcanzar concentraciones intraamnióticas adecuadas.

Formas clínicas

La enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B es la principal causa de Infección bacteriana neonatal. Se define por el aislamiento de *Streptococcus agalactiae* en sangre, líquido cefalorraquídeo (LCR) u otro sitio normalmente estéril.

Las formas clínicas de presentación son: Sepsis neonatal temprana (< de 7 días de vida) o tardía (entre 7 a 90 días de vida), meningitis, neumonía.

En la enfermedad invasiva temprana por SGB las manifestaciones clínicas pueden presentarse desde taquicardia, taquipnea, inestabilidad térmica, irritabilidad, letargo, rechazo alimentario, ictericia, apneas hasta insuficiencia cardio respiratoria grave, hipertensión pulmonar persistente y encefalopatía neonatal.

La mortalidad es más alta en pretérminos de muy bajo peso. En la enfermedad invasiva tardía por SGB las formas de presentación más frecuentes son: bacteriemia sin foco, meningitis con o sin bacteriemia, síndromes focales (compromiso osteoarticular, peritonitis, empiema pleural, celulitis, adenitis, infecciones del tracto urinario). La mortalidad atribuible a esta forma tardía es mayor por meningitis y en pretérminos.

En la forma tardía también se considera la transmisión horizontal que podría formar parte de la patogénesis.

Estudios complementarios

Laboratorio bioquímico: Hemograma con plaquetas, hepatograma, ERS, proteína C reactiva.

Estudios microbiológicos: Hemocultivos periféricos, PL para cultivo de LCR y examen citofisicoquímico, cultivo de orina, cultivo de líquido pleural, articular, de material óseo.

Estudios por imágenes: RX de tórax, Ecografías transfontanelar, Tomografía axial computada, Resonancia nuclear magnética.

Evaluación del riesgo para Sepsis neonatal temprana o enfermedad invasiva temprana

En neonatos > a 35 semanas identificar fiebre intraparto igual o > a 38 °C, el uso adecuado de profilaxis antibiótica para SGB, duración de ruptura ovular de membranas, signos clínicos de enfermedad al nacer o en las primeras 48 Hs.

Tratamiento

Tratamiento antibiótico empírico iniciales el mismo que en sepsis neonatal temprana bacteriana

- ≤ 7 días de vida: Ampicilina 200 mg/Kg/día

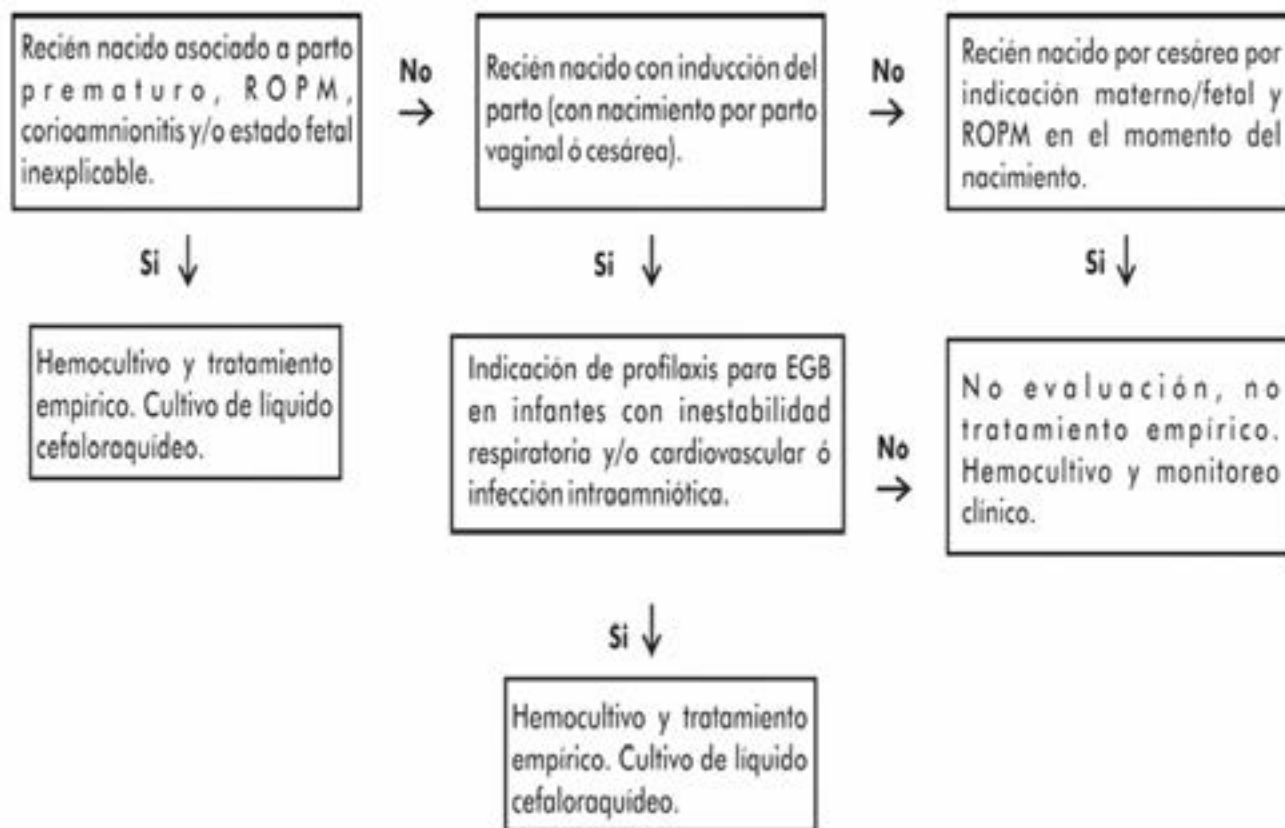


Gráfico 5-Evaluación del riesgo para Sepsis neonatal temprana en neonatos < de 34 semanas para determinar estrategias, en distintos escenarios clínicos. Adaptado y modificado (35)

	Edad gestacional: < 34 semanas		Edad gestacional: > 34 semanas	
	≤ 7 días de vida	> 7 días de vida	≤ 7 días de vida	> 7 días de vida
Bacteriemia Ampicilina Penicilina G	50 mg/Kg c/12 Hs 50.000 U/kg c/12 HS	75 mg/Kg c/12 Hs 50.000 U/kg c/8 HS	50 mg/Kg c/ 8 Hs 50.000 U/kg c/12 HS	50 mg/Kg c/8 Hs 50.000 U/kg c/8 HS
Meningitis Ampicilina Penicilina G	100 mg/Kg c/ 8 Hs 150.000 U/kg c/8 HS	75 mg/Kg c/6 Hs 125.000 U/kg c/ 6HS	100 mg/Kg c/ 8 Hs 150.000 U/kg c/8 HS	74 mg/Kg c/ 6 Hs 125.000 U/kg c/6 HS

Cuadro 5: Esquemas antibióticos EV recomendados en Enfermedad temprana y tardía por SGB (37)

cada 12 Hs, EV + gentamicina 4 mg/Kg/día cada 24 hs, EV.

- 8 a 28 días de vida: Ampicilina 300 mg/Kg/día cada 12 Hs, EV + Cefotaxima (si no está gravemente enfermo y sin evidencia de meningitis).
- 29 a 90 días de vida: Ceftriaxona (si hubiere estado crítico o evidencia de meningitis agregar Vancomicina)
- Tratamiento antibiótico recomendado en enfermedad invasiva temprana y tardía con aislamiento de SGB por cultivo (cuadro 5).

Vacunas anti SGB

Se encuentran en desarrollo, multivalentes, en estudios preclínicos y humano en fase I y II. Para prevenir potencialmente infecciones invasivas en el recién nacido al administrarlas a la embarazada y en adultos de alto riesgo.

Comentario Final

El trabajo en red es indispensable para realizar un abordaje integral, interdisciplinario, entre los equipos de salud, articulando los distintos niveles de atención, a fin de lograr prevención de las infecciones pre y perinatales, a través del cuidado del ambiente y educación en hábitos saludables; diagnóstico temprano, para impedir progresión de la enfermedad; tratamiento oportuno y rehabilitación en busca de la mejor

calidad de vida posible (38).

Es fundamental para el trabajo en equipo la construcción de redes desde el reconocimiento, el conocimiento, con cooperación, colaboración y asociación del trabajo conjunto (39).

Desde el primer nivel de atención, educar e informar a la mujer en edad fértil, a la gestante, parejas sexuales, de los cuidados y controles para prevenir las infecciones perinatales, tanto las mencionadas en este capítulo, que se deben pesquisar en toda embarazada, como así también aquellas que deben ser abordadas según diversos escenarios, ante situaciones de exposición, procedencia, ocupación, viajes, antecedentes previos, hábitos tóxicos de riesgo, entre otros, para identificar posibles contactos con rubéola, infección por CMV, hepatitis C, infección por parvovirus B19, herpes simple, varicela, infección gonocócica, *Listeria monocytogenes*, infección por virus Zika. Por lo que se debe articular con los distintos niveles de atención para el seguimiento personalizado de la madre y el niño.

Cabe destacar, ante el impacto de las enfermedades congénitas descritas en el neonato y el niño la importancia que toman las medidas de prevención.

“Acompañar siempre, curar tal vez” (Dr. Carlos Gianantonio)

Referencias bibliográficas

1. Cofré F, Delpiano L, Labraña Y, Reyes A, Sandoval A, Izquierdo G. Síndrome de TORCH: enfoque racional del diagnóstico y tratamiento pre y postnatal. Recomendaciones del Comité Consultivo de Infecciones neonatales Sociedad Chilena de infectología. *Rev Chilena Infectol* 2016; 33 (2): 191-216
2. Rosso F, Agudelo A, Isaza A, Montoya J. Toxoplasmosis congénita: aspectos clínicos y epidemiológicos de la infección durante el embarazo. *Colomb Médica* 2007; 38 (3): 316-337
3. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaffler MA *Microbiología Médica* 8º ed. Barcelona Elsevier, 2017
4. Durlach R, Kaufer F, Carral L, Freuler C, Cerotto M, Rodríguez M et al. Asociación Argentina de Zoonosis. Consenso Argentino de Toxoplasmosis congénita Medicina (Buenos Aires) 2008; 68: 75-78
5. Carral L, Kaufer F, Pardini L, Durlach R, Moré G, Venturini M, et al. Toxoplasmosis congénita: Diagnóstico serológico, RCP, aislamiento y caracterización molecular de toxoplasma gondii. *Rev Chilena Infectol* 2018; 35 (1): 36-40
6. Badia Barnusell J, Figaró Volta C, Salvia M, Domingo Puiggrós M, Aldecao Bilbao. Infecciones congénitas. *Pediatr Integral* 2014; XVIII (6):356-366
7. Maldonado YA, Read JS. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Congénita Toxoplasmosis in the United States. *Pediatrics* 2017; 139 (2): e20163860.
8. Ministerio de salud de la Nación. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Guía de prevención y tratamiento de las infecciones congénitas y perinatales. Ed Unicef. 2010.
9. Ministerio de Salud de la Nación. Boletín sobre el VIH, Sida e ITS en la Argentina. Estrategia de intervención para la prevención de sífilis materna y congénita en la provincia de Buenos Aires. N° 36. Año XXII.2019
10. Mattarollo P, Bernstein J. Sífilis congénita, una infección evitable en aumento. Revista de publicación Bianual. Colegio de Médicos. Distrito I. Provincia de Buenos Aires. 2018
11. Bolomo G, Campoy M, Garritano M, Miraglia E, Gómez Sierra M, Ibáñez M, et al. Sífilis adquirida y congénita: nuestra experiencia en el Consultorio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del HIGA San Martín de La Plata (2011-2015). *Med Cutan Iber Lat Am* 2016; 44 (3): 198-205
12. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de VIH, ITS y hepatitis virales en la provincia de Buenos Aires. *Boletín Epidemiológico* 2018; N° 400; p:77
13. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dirección de VIH/ITS/ y HV de la provincia de Buenos Aires. Acceso al diagnóstico HIV y Sífilis provincia de Buenos Aires 2019
14. Organización Panamericana de la Salud. ETMI-PLUS. Marco para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de chagas. Informe de grupo científico de OPS. 2017
15. Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Cheng XS, Radolf JD, Schwartz A. Syphilis. *Nat rev Dis Primers* 2017 12,3: 17073
16. Tsmis ME, Sheffield JS, Update on syphilis and pregnancy *Birth Defects Res* 2017; 109 (5): 347-352
17. Kittipornpechdee N, Hanamornroomruang S, Lekmark D y Teetip-satit J, Fetal and pediatric Pathology 2018; 37 (4): 231-242
18. CDC. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. *MMWR* 2015; 64 (3):34
19. Cooper JM, Sánchez PJ. Congenital syphilis. *Seminars in Perinatology* 2018; 42:176-184
20. Ministerio de Salud, Argentina. Dirección de Sida y ETS, Prevención de la transmisión perinatal de sífilis, hepatitis B y VIH. Recomendaciones para el trabajo de los equipos de salud, 2016
21. Mitelman J y Col. Consenso de enfermedad de Chagas-Mazza, Sociedad Argentina de Cardiología; Revista de Cardiología 2011; 79 (6):525
22. Chuit R y col. El control de la enfermedad de Chagas en Argentina: Sus resultados. *Rev Fed Arg Cardiol* 2012; 41 (3):151-155
23. Organización Panamericana de la Salud. Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas. 2019. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/10665.2/49653>.
24. Ministerio de Salud de la Nación. Guía para la atención al paciente con Enfermedad de Chagas. 2018.
25. Clasificación Internacional de Enfermedades 10º .Hepatitis viral congénita (CIE-10:P35.3).
26. Nardone A, Anastassopoulou CG, Theeten H, Kriz B, Davidkin I, Thierfelder W, et al. Comparison of hepatitis B seroepidemiology in ten European countries *Epidemiol Infect*. 2009; 137(7):961-962
27. Walz A, Wirth S, Hücke J, Gerner P. Vertical transmission of hepatitis B virus (HBV) from mothers negative for HBV surface antigen and positive for antibody HBV core antigen. *J Infect Dis* 2009 15;200(8):1227-31
28. VI Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2016-2017.
29. VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2018-2019.
30. Gaiano A, Bruno M, Vulcano S, Bologna R, Moyano M, Adaszko A, et al. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de SIDA y ETS. Guía para la atención de niños, niñas y adolescentes con HIV y con exposición perinatal. 2016.
31. Yagw R, Goul Ghadwick E. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (virus de la inmunodeficiencia humana). En. Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor N. Nelson Tratado de Pediatría. Edición 20. España. Editorial: Elsevier; 2016.p. 1725-1748.
32. American Academy of Pediatrics. Red Book: Atlas de enfermedades infecciosas en pediatría. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Editorial Panamericana 2009; 64: p172-179
33. Chávez A, Álvarez A, Wu E. Transmisión vertical del virus inmunodeficiencia humana: impacto de la aplicación del protocolo ACTG 076 en Chile. *Rev. Chilena infectol* 2000; 17:279-301
34. American College of Obstetricians and Gynecologists Prevention of group B streptococcal early-onset disease in newborns: ACOG Committee Opinion, Number 782. *Obstet Gynecol*.2019; 134(1):e 19-e40
35. Puopoldo KM, Lynfield R, Cummings JJ, et al. Management of infant at risk for group B streptococcal disease. *Pediatrics*2019; 144(2):e20191881
36. Hospital Alemán. Guía de profilaxis intraparto para Estreptococo grupo hemolítico grupo B. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Aleman. 2017.
37. American Academy of Pediatrics. Tables of Antibacterial Drugs Dosages. Kimberlin DW; Brady MT; Jackson MA; Long SS; Eds Red Book 2018 Report of the Committee on Infectious Disease; Pediatrics 2018:915-919
38. Del Prado J. Prevención primaria, secundaria y terciaria. IMC Business School-Blog de prevención de riesgos laborales.
39. Rovere, M. Redes en Salud; los Grupos, las Instituciones, la Comunidad. 3º edición. Ed. El Ágora 2016.

*Dra. Marisa Golowczyk

Especialista en Neonatología. Servicio de Pediatría Hospital Horacio Cestino.

**Dr. Adriana León

Especialista en Neonatología. Servicio de Pediatría Hospital Horacio Cestino.

***Dra. Daniela Moya

Especialista en Pediatra. Servicio de Pediatría Hospital Horacio Cestino.

****Dra. Yésica Ramos

Pediatra. Servicio de Pediatría Hospital Horacio Cestino.

*****Dra. Nora Patricia Mattarollo

Especialista Universitaria en Infectología.
Especialista en Infectología pediátrica. Prof. Adjunta Cátedra de Infectología. FCM-UNLP.
Coordinadora Agresión Infectológica- Inmunitaria. UNA).

DENGUE



DR. JUAN CARLOS DANIEL MORALES*

DRA. MARTA CECILIA VINUESA**

Sumario

El dengue es un Síndrome febril agudo producido por virus de la familia Flaviviridae. Existen 4 serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, los cuales son genética y antigénicamente diferentes. Es una enfermedad obligadamente transmitida por mosquitos. El número acumulado de notificaciones hasta el momento para la temporada 2019/2020 (SE31/2019 a SE16/20) es entre 6 y 8 veces más lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. Se ha instalado entre nosotros. De allí la importancia de su inclusión en Pediatría en red 3.

Generalidades

Etiología

Síndrome febril agudo producido por virus de la familia Flaviviridae. Existen 4 serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, los cuales son genética y antigénicamente diferentes. La Inmunidad que confiere cada uno de los serotipos es de por vida, pero específica para cada uno de ellos. Luego de la enfermedad hay una inmunidad heteróloga para el complejo dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4) de 2 a 6 meses. Después de ese período, se produce una inmunidad homóloga para el serotipo causal, durante toda la vida. La enfermedad también se la denomina fiebre quebrantahuesos. El reservorio son los humanos y primates.

Es una enfermedad obligadamente transmitida por mosquitos: *hombre (viremia febril de 6-7 días)-Mosquito hembra-Hombre*. El mos-

quito hembra pica y antes de chupar la sangre, inyecta el virus. La prevención debe dirigirse al vector.

Epidemiología

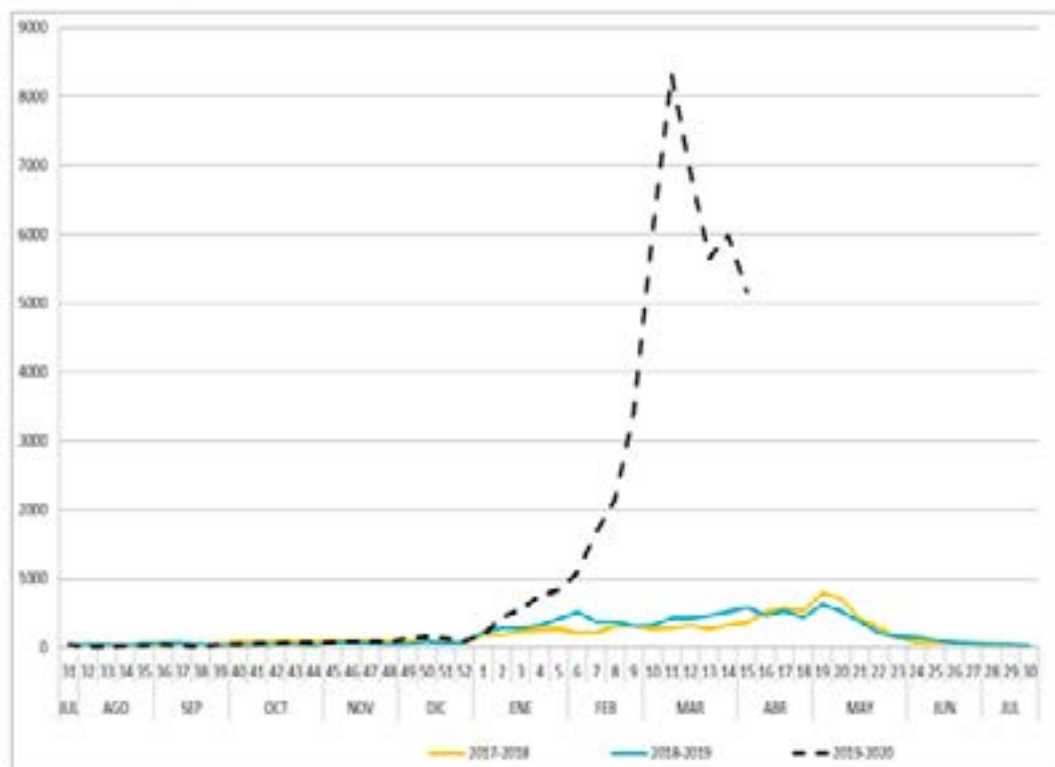
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros arbovirus se realiza por “temporada”, entendiendo por tal un período de 52 semanas desde el cierre del último brote de la temporada anterior. En el caso de 2019, se declaró cerrado el brote de la temporada 2018/2019 en la SE30 del 2019. Por lo tanto el análisis de la temporada 2019/2020 abarcará el período desde la SE31/2019 a la SE30/2020.

Para la temporada 2019-2020, el número de casos sospechosos notificados por semana se comportó de manera similar a lo notificado en las dos temporadas previas hasta la SE1 de 2020. A partir de entonces y hasta la semana 12, el número de notificaciones por semana es muy superior a los dos años previos. El número acumulado de notificaciones hasta el momento para la temporada 2019/2020 (SE31/2019 a SE16/20) es entre 6 y 8 veces más lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. Gráfico 1

A nivel país, se observa que esta temporada tuvo un máximo de casos en la semana 11 con un posterior descenso hasta la semana 12, donde vuelve a aumentar para alcanzar un segundo máximo en la semana 14.

Hasta el momento, se registraron en diferentes sitios del territorio nacional la presencia de

Gráfico 1. Casos de arbovirosis notificados por semana epidemiológica de inicio de síntomas o consulta. Período entre semanas epidemiológicas 31 a 30. Años 2017, 2018, 2019 y 2020.



Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) -Módulos C2 y SIVILA- y del SNVS 2.0.

3 serotipos: 70% correspondió a DEN-1, 27% a DEN-4 y 3% DEN-2.

Es una enfermedad reemergente, que afecta progresivamente nuevas áreas, relacionado con el cambio climático de los últimos 60 años. La Población en riesgo en Argentina es de 21 millones de personas.

El espectro de la infección incluye un cuadro asintomático, una infección febril inespecífica, la forma clásica de dengue o la forma hemorrágica grave. Las manifestaciones más leves tienden a ocurrir en niños pequeños.

La primera infección causa el dengue clásico (buen pronóstico), mientras que la reinfección por un serotipo diferente se asocia al desarrollo del dengue hemorrágico con o sin shock circulatorio (con elevada letalidad, especialmente si la atención médica no es oportuna).

En el año 2009 la enfermedad adquirió una nueva clasificación (dengue con signos de alarma y dengue grave) para facilitar el reconocimiento médico clínico temprano y el tratamiento oportuno.

El virus es transmitido principalmente por la mosquito hembra *Aedes aegypti* y en los últimos años también por *Aedes albopictus*. Una vez la mosquito pica a un hombre, se torna infectante a los 8-12 días y permanece infectante durante todo su ciclo de vida (1 a 4 meses).

Los huevos tienen un desarrollo embrionario de 2 – 5 días y pasan por diferentes estadios: cuatro estadios larvarios (acuático, 5 – 14 días)

Pupa (acuático, 2 – 3 días), luego a mosquito adulto.

La mosquito adulto habita entre los 35° latitud norte y 35° latitud sur (Argentina, 37,2°), con temperaturas de 15° a 40° C (isoterma 14,5°), con una altura de vuelo de hasta 2.200 m sobre el nivel del mar. Se calcula que los mosquitos *Aedes spp* viven en promedio 1 mes.

Los Huevos de los mosquitos resisten de una temporada a otra. Los criaderos están fuera de las casas. Los mosquitos ponen hasta 1000 huevos de una sola vez, pero en 8 o 10 lugares diferentes, donde hay agua limpia (instinto o afán de mantener la especie).

La mortalidad diaria de los mismos es de 10% a

50% a la semana y 95% al mes. Cada Mosquito puede picar a 20 o más personas.

Son factores fundamentales para la actividad de los mosquitos y de la enfermedad: aguas estancadas, recipientes en desuso, hábitat domiciliario y peri domiciliario de los mosquitos, densidad de la población, patrones de asentamiento, viviendas precarias, abastecimiento inadecuado de agua, recolección y disposición de desechos sólidos, estado socioeconómico cultural, períodos inactivos en la casa durante el día, conocimiento de las enfermedades que transmite en la población (fundamental).

Clínica

Manifestaciones clínicas: es una enfermedad sistémica y dinámica. El amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas graves y no graves. Después del período de incubación, la enfermedad se desarrolla y básicamente es seguida de tres fases:

- ✓ Febril
- ✓ Crítica
- ✓ De recuperación
- ✓ Es dinámica, comienza y va progresando.
- ✓ Período de incubación: 3-14 días (Promedio de 5 a 7 días)
- ✓ Período de invasión: no delimitado aún

Existen diferentes formas clínicas

- ✓ Asintomática
- ✓ Síndrome febril indiferenciado
- ✓ Síndrome febril indiferenciado con mialgias/artralgias
- ✓ Síndrome febril indiferenciado en exantema
- ✓ Dengue clásico
- ✓ Dengue hemorrágico o Fiebre hemorrágica por Dengue
- ✓ Shock por dengue
- ✓ Dengue atípico o visceral o complicado
- ✓ Dengue prenatal o perinatal

Caso Sospechoso de Dengue

Persona con enfermedad febril aguda de hasta 7 días, sin compromiso de la vía respiratoria ni foco aparente, con dos o más de las siguientes manifestaciones clínicas:

- ✓ cefalea frontal
- ✓ dolor retroocular

- ✓ mialgias
- ✓ artralgias
- ✓ exantema eritemato-máculo-papular (25%) o presencia en la misma localidad y en el mismo período de otros casos confirmados de dengue

El paciente con dengue puede presentar: fiebre (hasta 40 ° C). La fiebre acompaña a la viremia. Tiene importancia clínica y epidemiológica. Mientras tiene fiebre, tiene viremia y va a transmitir y propagar la enfermedad. La fiebre es variable (3 días-5, 6 o 7 días). Es una enfermedad de 7 días o menos.

Se acompaña de náuseas, vómitos, exantema eritemato-máculo-papular morbiliforme, escarlatiniforme o hemorrágico, generalizado o con distribución predominante en zonas de flexión o pliegues, que puede ser pruriginoso, enantema, inyección conjuntival, faringoamigdalitis eritemato ramosa o eritemato ramosa petequial, edema gingival (ribete gingival) lengua saburral, mialgias importantes generalizadas o artralgias, prueba del torniquete positiva y leucopenia, manifestaciones digestivas (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hiporexia marcada, alteraciones en el gusto (hipogeusia, disgeusia, ageusia), cefalea, dolor retroocular, alternancia de constipación con diarrea, hepatomegalia, esplenomegalia (menos frecuente), manifestaciones cardiovasculares/circulatorias: hipotensión arterial, bradicardia relativa, prueba del Lazo, torniquete o Rumpel Leede Positiva.

Signos de Alarma

Dolor abdominal grave, vómitos persistentes, acumulación de líquido en terceros espacios (derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico) detectados clínicamente o por ecografía o radiografía de tórax, aumento del diámetro de la pared de la vesícula biliar (más de 5 a 7 mm). El edema de la pared vesicular duele y semeja una colecistitis, que puede requerir cirugía, con importante mortalidad, debido a la inestabilidad del paciente.

Otras veces puede haber edema difuso de las asas intestinales y el retroperitoneo. Puede presentarse sangrado de mucosas, letargia/alteración del estado de alerta, hepatomegalia dolorosa, incremento del hematocrito (hemoconcentración) y plaquetopenia. El paciente

puede presentar deshidratación, motivo por el cual se le debe ofrecer tomar abundante cantidad de líquidos desde el primer día, si tiene buena tolerancia oral.

La presencia de los signos de alarma, nos está indicando que el paciente está cursando la fase crítica de la enfermedad (entre el día 4 y el 6 o 7). Con la caída o defervescencia de la fiebre, comienza la etapa crítica de la enfermedad (cambio de paradigma). Aquí es al revés de lo que ocurre con otras enfermedades.

En el dengue, la caída de la fiebre indica gravedad del cuadro. Hay importante extravasación de plasma, por lo que sube el hematocrito (hemoconcentración y descienden las plaquetas. El Hematocrito que era normal, comienza a elevarse por extravasación capilar con hemoconcentración. Las plaquetas que estaban normales comienzan a caer, porque hay destrucción masiva de plaquetas, por mecanismos inmunomediados. La médula ósea está normal o hiperplásica, tratando de reponer las plaquetas.

Los anticuerpos que el organismo elabora contra el virus, tienen reacción cruzada y efecto destructivo contra las plaquetas, fruto de la tormenta inmunológica de citoquinas transitoria. En estas circunstancias, se debe indicar reposo absoluto y no infundir plaquetas, porque el propio organismo las va a destruir.

El dengue es crítico no por las hemorragias, sino por el escape de agua, sodio, albúmina y ocurre por afectación o daño especial en los endotelios. El virus dengue es capaz de inducir apoptosis en el endotelio vascular generalizado, con liberación brusca de una gran cantidad de citoquinas. En esta etapa el gran peligro es el shock y las hemorragias, que pueden acompañarse de fallo circulatorio grave, con coagulación intravascular diseminada, fallo multiorgánico y muerte.

La Fase convaleciente puede acompañarse de debilidad física y cansancio durante varias semanas. Se reabsorben los edemas, las plaquetas se recuperan, el hematocrito se normaliza y aparece la IgM.

Dengue grave, hemorrágico o fiebre hemorrágica por Dengue

Tiene un comienzo brusco, con Hipertermia (40° C), odinofagia, Inyección conjuntival y

manifestaciones digestivas marcadas (hiporexia, vómitos, dolor abdominal).

El paciente presenta fiebre continua durante 2 a 7 días, diatesis hemorrágica, (exantema hemorrágico, gingivorragias, hemorragias), hepatomegalia, alteraciones circulatorias, shock hipovolémico.

Hay shock con acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, sangrados importantes secos y húmedos, disfunción orgánica (Aumento de TGO-TGP $\geq$ a 1000 UI/ml, alteración del estado de alerta, compromiso miocárdico (pulso rápido y débil, hipotensión arterial con tensión arterial diferencial disminuida, piel fría y húmeda), y compromiso de otros órganos.

Caso Sospechoso de Dengue Grave, Hemorrágico o Fiebre hemorrágica por Dengue

- ✓ Fiebre (39-40°C)
- ✓ Manifestaciones hemorrágicas: al menos la prueba del lazo/torniquete positiva. Petequias, púrpura, equimosis, epistaxis, hemorragia gingival, y/o del tracto intestinal, hematemesis y/o melena.
- ✓ Trombocitopenia: menor o igual a 100.000 plaquetas por mm³
- ✓ Extravasación de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular capilar, manifestada al menos por índice de hematocrito inicial aumentado en $\geq$ a 20 % después del tratamiento, signos comunes asociados: derrame pleural, ascitis, hidropericardio e hipoproteínemia

Caso Sospechoso de Shock por Dengue

Todos los criterios anteriores, sumado a:

- ✓ Hipotensión arterial o estrechamiento de la tensión arterial diferencial en (20 mm Hg)
- ✓ Pulso rápido, débil, filiforme, piel húmeda y fría, agitación psicomotriz
- ✓ El síndrome de Shock por Dengue presenta: dolor abdominal intenso, vómitos, alteración del estado de la conciencia (agitación o letargia), disminución brusca de la temperatura con sudoración profusa y taquicardia, oliguria, oligoanuria, cianosis, hipotensión arterial y ascenso brusco del hematocrito (hemoconcentración).

Dengue visceral

Es un cuadro clínico indistinguible de la fiebre amarilla. Fue descrito en Río de Janeiro en 1984. Presenta hepatitis fulminante, encefalopatía y miopericarditis, con alta mortalidad.

Dengue prenatal/perinatal

La transmisión vertical del dengue ha sido descrita con un porcentaje que oscila entre 12 % y 64%. Las mujeres gestantes asintomáticas, pueden transmitir el virus por vía vertical en un 1,5 %, pudiendo dar a luz a recién nacidos de pretérmino en 16 %, y a recién nacidos con bajo peso al nacer en un 4 %.

Signos de alarma de Dengue

Es muy importante el reconocimiento temprano de los mismos, para instaurar medidas terapéuticas inmediatas.

- ✓ Dolor abdominal intenso y sostenido espontáneo o a la palpación
- ✓ Vómitos frecuentes y abundantes
- ✓ Hipotensión ortostática
- ✓ Lipotimia
- ✓ Sangrados secos y húmedos
- ✓ Disminución brusca de la temperatura (No significa que el paciente se está curando)
- ✓ Alteración del estado de conciencia (agitación, estupor, letargia), en un paciente que esta afebril

Diagnóstico

Epidemiológico: anamnesis clínico- epidemiológica exhaustiva

Clínico

Métodos complementarios de laboratorio

De rutina

Directos

Indirectos

Hallazgos de laboratorio

Analítica sanguínea

Dengue Clásico: leucopenia con discreta linfocitosis y ocasional aumento de neutrófilos en cayado, presencia de linfocitos activados, plaquetas normales o plaquetopenia, prueba del torniquete ocasionalmente positiva, velocidad de eritrosedimentación usualmente normal, hipoproteinemia, hiponatremia, elevación discreta de las transaminasas y de la urea.

Dengue grave: trombocitopenia (<100.000 plaquetas $\times \text{mm}^3$), aumento del hematocrito en $> 20 \%$, prueba del torniquete positiva (con el mango del esfigmomanómetro mantenga una presión hasta un punto más entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos; si se observan 20 o más petequias por pulgada cuadrada, la prueba se considera positiva)

Métodos directos

Detección de antígeno NS1

Amplificación de ácidos nucleicos: Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Cultivo viral: aislamiento del virus del dengue en cultivo de células (muestra de sangre recogida durante los 4 primeros días de la enfermedad)

Métodos indirectos

IgM

IgG par serológico

Serología (IgG e IgM específicas para dengue determinadas por ELISA, hemaglutinación, neutralización o inmunofluorescencia) obtenidas durante la fase aguda y la convalecencia (8 días después de la primera muestra). La IgM positiva o el aumento de más de cuatro veces en el título de IgG confirman el diagnóstico.

Caso Confirmado de dengue

Caso sospechoso con RT PCR positiva antes del 5to día o prueba de neutralización positiva en muestra pareada obtenida a partir del 5to día de la enfermedad

Caso Probable de dengue

Caso sospechoso con determinación de Ag NS1 antes del 5to día o Serología (una determinación) positiva de IgM en la etapa aguda, a partir del 5to día de la enfermedad

Diagnósticos diferenciales

Paludismo (primer diagnóstico diferencial en el post viaje)

Hepatitis Infecciosa

Fiebre Amarilla

Rubéola

Sarampión

Influenza (tiene rinorrea, rinitis, mocos)

Infección por *Neisseria meningitidis*

Leptospiriosis
Hantavirosis Pulmonar

Tratamiento

- ✓ Reposo absoluto y aislamiento de los mosquitos mediante el uso de repelentes o uso de tul.
- ✓ Control de la temperatura por medios físicos, administración de Paracetamol (Acetaminofeno) a la dosis de 10 a 15 mg/Kg/día en niños, cada 8 horas, vía oral, y 2 g/día en adultos, cada 8 horas, vía oral, ingesta de abundantes líquidos orales, alimentación según tolerancia.
- ✓ Está prohibido el uso de salicilatos (Aspirina) y otros DAINES. No administrar corticoides ni antibióticos.
- ✓ Todo esto debe estar adecuadamente consignado en un instructivo, junto con los signos de alarma. Se debe evitar la vía intramuscular para la administración de drogas.

FAMILY - desde los 2 meses. .

- ✓ Aerosol DEET 15 a 20%(renovar cada 6 horas)
- ✓ Crema DEET 7-20%(renovar cada 2 horas) .
- ✓ Spray DEET 7-20%(renovar 2 horas)

KIDS - desde los 2 meses.

- ✓ Crema DEET 7.5%(renovar cada 2 horas) .
- ✓ Spray DEET 7%(renovar 2 horas)

ACTIVE - desde los 6 meses. (Extra duración)

- ✓ Aerosol DEET 25%(renovar cada 12 horas) .
- ✓ Crema DEET 25%(renovar cada 8 horas) .
- ✓ Spray DEET 25%(renovar cada 8 horas)

DEFENSE Infantil .

- ✓ Crema ICARIDINA 20%(renovar cada 12 horas) desde los 6 meses.
- ✓ Spray ICARIDINA 25%(renovar cada 12 horas) desde los 2 años. .
- ✓ BOTÁNICALS 10%diol (renovar cada 2 horas) desde los 3 años .

Repelentes

SÍNDROME FEBRIL AGUDO INESPECÍFICO (SFAI)
FORM DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LABORATORIO

Definición de caso sospechoso: Todo paciente que presenta al momento de la consulta (o haya presentado en los últimos 48 días) fiebre aguda de menos de siete (7) días de duración, mialgia o cefalea, con al menos de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

Fecha de notificación: Día Mes Año. Cui del paciente: _____

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: Apellido y nombre: _____

Fecha de nacimiento: Día Mes Año Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino

Condición: Caso ☐ No caso ☐ Sin caso ☐

Berth: _____

Referencia de atención: _____ Año: Urbano ☐ Rural ☐

Localidad: _____ Departamento: _____ Provincia: _____

Teléfono: _____ Teléfono alternativo (familia o contacto): _____

EXAMEN CLÍNICO: Fecha de consulta: _____ Consulta preoperatoria? ☐ Si ☐ No Fecha: _____

Fecha de inicio de la fiebre: _____ Ambulatorio ☐ Internado ☐ Fecha de internación: _____

Examen: ☐

EXPECIFICAR SI PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUENTES SIGNOS, SÍNTOMAS O PARÁMETROS DE LABORATORIO:

Signos y síntomas	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Fiebre mayor a 38°C	☐	☐	Exantema	☐	☐	☐	☐	☐
Cefalea	☐	☐	Neutrofilia	☐	☐	☐	☐	☐
Mialgia	☐	☐	Eosinofilia	☐	☐	☐	☐	☐
Ataxia	☐	☐	Organopatía	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la audición	☐	☐	Endroto hematógeno	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la visión	☐	☐	Tos	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la audición	☐	☐	Resaca	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la audición	☐	☐	Síndrome Confusional	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la audición	☐	☐	Síndrome delirio	☐	☐	☐	☐	☐
Alteración de la audición	☐	☐	Alta de base	☐	☐	☐	☐	☐

Marcar con una X: Fiebre ☐ Fiebre ☐ Espasmo ☐ Gorgoropio ☐ Temblores ☐ Mialgia ☐ Síndrome ☐ Otro ☐

44 Sexo: _____

Edad: _____ Meses _____ Años _____

Uso: Ingesta ☐ Creatina ☐ Ingesta ☐ ALT-GPT ☐ UCL ☐ AST-GPT ☐ UCL ☐ RAL ☐ UCL

DATOS DE LA MUESTRA PARA ESTUDIO ETIOLÓGICO (a completar por el laboratorio notificado):

Fecha de TOME PRIMERA MUESTRA: _____

Fecha de TOME SEGUNDA MUESTRA: _____

DIAGNÓSTICO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO / RESULTADO DE ESTUDIOS PARA DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

Clasificación de la etiología: ☐ No se pudo determinar la etiología ☐ Se pudo determinar la etiología (a completar por el laboratorio notificado)

Clasificación	Clasificación
Leishmaniasis	Fiebre hemorrágica Argentina
Hantavirus	Encefalitis de San Luis
Chikungunya	Fiebre del Nilo Occidental
Dengue	Aciclovir
Psittacosis	Otras infecciones

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

¿Visto antes en otros 48 días? ☐ Si ☐ No Fecha de vista: _____

Fecha de ingreso: _____

¿Este paciente es trabajador de la industria?

País	Provincia	Departamento	Localidad
_____	_____	_____	_____

¿Este caso es parte del monitoreo de un brote en curso? ☐ Si ☐ No ¿De qué origen?

¿Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? ☐ Si ☐ No Fecha: _____ Lugar: _____

¿Estuvo en contacto con animales? ☐ Si ☐ No ¿De qué tipo?

¿Consumió carne silvestre? ☐ Si ☐ No ¿De qué tipo?

ANTECEDENTES:

Tubo dengue previamente ☐ Si ☐ No Año: _____

Vacunación antiamarilla ☐ Si ☐ No Fecha: _____

Vacunación Fiebre hemorrágica Argentina ☐ Si ☐ No Fecha: _____

Vacunación Leishmaniasis ☐ Si ☐ No Fecha: _____

EVOLUCIÓN DEL CASO A LA REGIÓN

Condición de ingreso: Visto ☐ No ☐ Fecha: _____

Fecha de alta: _____

Fecha de defunción: _____

Fecha de internación: _____

ESTABLECIMIENTO: _____

Departamento: _____ Localidad: _____

DATOS DEL MÉDICO:

Apellido y nombre: _____

Firma: _____

Correo electrónico: _____

Fecha de notificación: _____

2

Ficha Epidemiológica para Notificación al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud

Tratamiento del Shock: manejo agresivo de líquidos (solución salina normal o solución de Ringer Lactato a 20 ml /Kg en 1 hora: mantener Hidratación Parenteral a 1500-2000 ml/día y natremia 40 -50 meq/m2/día, con reposición de pérdidas hídricas según el balance hidroelectrolítico y la medición de la diuresis.

Prevención

- ✓ Fumigación con insecticidas para matar a los vectores (mosquitos adultos). La fumigación no es muy efectiva porque los huevos, las larvas y las pupas, no son eliminadas con los insecticidas, por lo que luego de un tiempo se transforman en mosquitos adultos. Hay que realizar fumigaciones, pero lo más importante es acabar con los criaderos de mosquitos (recipientes con agua, tanques para almacenamiento de agua, floreros, neumáticos en desuso, cacharros etc.), tarea sumamente difícil.
- ✓ Eliminación de criaderos de mosquitos
- ✓ Uso de Repelentes (OFF®)

Vacunación: uso recomendado de nueva vacuna (dengvaxia) en poblaciones de alta endemicidad (seroprevalencia de 70-80 %), en edades entre 9 y 45 años. Eficaz para prevenir enfermedad grave. Reducida efectividad en seronegativos y contra serotipo DEN 2.

¿Cuándo referir al paciente a un Centro de Mayor complejidad/Terapia Intensiva?

- A todo paciente con sospecha o confirmación de dengue, que presente signos de alarma o hallazgos de dengue grave
- Todo paciente con dengue y comorbilidades, o que tenga riesgo social para seguimiento adecuado

Bibliografía

- American Academy of Pediatrics. Dengue. En: Kimberlin D. Red Book 2015. Informe del Comité sobre Enfermedades Infecciosas, 30ª edición. Elk Grove Village, IL. Academia Americana de Pediatría; Pág 322-325.
- Arce M. Enfermedades Reemergentes. Dengue y Leishmaniasis visceral. Sociedad Argentina de Pediatría. TIPs Programa de Actualización. Temas de Infectología Pediátrica, Volumen 7, 2014, Pág 37-70.
- Argentina. Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica. Boletín Integrado de Vigilancia. Edición Semanal, N° 494 SE 16, año 2020., Pág 1-90.
- Argentina. Ministerio de Salud. Enfermedades Infecciosas. Dengue. Diagnóstico de Dengue. Guía para el Equipo de Salud. 3ª Ed, 2013. Pág 1-56.
- Del Angel R, Ludert J, Reyes J. Dengue. En: Virología Clínica. Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 2011, Pág 262-267.
- Martínez Torres E. Dengue. En: Infectología Clínica Pediátrica. Mc Graw-Hill, Octava Edición, 2011; Pág 559-567.
- Organización Mundial de la Salud. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control. 2nd ed. Geneva: World Health Organization.
- Pizarro D, Alfaro A, Odio C. Dengue. Dengue hemorrágico. En: Delgado Rubio A. Enfermedades Infecciosas en Pediatría. Mc Graw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U 2009; Pág 445-453.
- Rigau Pérez JG. Severe Dengue: the need for new case definitions. Lancet Infect Dis 2006; 6 297-302.
- Seijo A. Dengue. En: Atlas de Zoonosis y Enfermedades Emergentes. Fundación Mundo Sano www.mundosano.org 1era Edición, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 2015, Pág 17-28.

*Dr. Juan Carlos Daniel Morales

Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas "Prof. Dr. Emilio Cecchini", Hospital de Niños Superiora "Sor María Ludovica" de La Plata

**Dra. Cecilia Vinuesa

Médica de Planta Servicio de Enfermedades Infecciosas "Prof. Dr. Emilio Cecchini", Hospital de Niños Superiora "Sor María Ludovica" de La Plata

ACERCA DEL COVID 19 EN PEDIATRÍA



DR. JUAN CARLOS DANIEL MORALES*

DRA. CECILIA VINUESA**

Sumario

La Infección por SARS CoV-2 (COVID-19), es una enfermedad viral emergente, actualmente vigente desde fines del 2019 a la fecha, de características pandémicas, desde el 30 de enero de 2019 cuando la Organización mundial de la Salud (OMS) declaró la Pandemia.

Es una enfermedad producida por un virus ARN, que tiene una tasa de contagio y diseminación importante, sobre todo en comunidades cerradas, con necesidades básicas insatisfechas y también en el Personal de Salud, expuesto al virus en sus lugares de trabajo, sobre todo en aquellos que no cumplen con las medidas de utilización con el equipo de protección personal (EPP), no mantienen la distancia social recomendada de 2 metros y no se lavan las manos de manera periódica y continua durante sus tareas.

Introducción

La enfermedad tiene un período de incubación de 5 a 24 días (promedio 14 días) y el paciente empieza a contagiar 24 a 48 horas antes de comenzados los síntomas, con una mortalidad de 3,4 %, calculándose estimativamente que una persona infectada, puede contagiar entre 1,45 y 4 personas.

La enfermedad tiene un espectro clínico que se clasifica a los fines prácticos en: asintomáticos, leves, moderados, graves y gravísimos.

Las formas asintomáticas constituyen un 80%, y son las que más contagian, sobre todo a nivel comunitario porque los pacientes desconocen que están infectados y diseminan el

virus. Los pacientes pediátricos que en la gran mayoría son asintomáticos, según los reportes bibliográficos, tienen cargas virales más altas y son más contagiantes.

Las formas leves moderadas cursan con fiebre (92%), tos, dificultad respiratoria, odinofagia, y disgeusia-ageusia, anosmia. Habitualmente no hay cefalea intensa, dolor retroocular ni rinitis serosa, lo que permitiría hacer el diagnóstico diferencial con Influenza.

Las formas graves y gravísimas cursan con un síndrome de dificultad respiratoria grave, neumonía intersticial, neumonía con compromiso alveolar con requerimientos de oxígeno por diferentes dispositivos hasta la Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM), fallo multiorgánico, con coagulación intravascular diseminada.

Generalmente las formas graves-gravísimas ocurren en personas mayores de 60 años, o que presentan comorbilidades asociadas: cardiopatías congénitas o adquiridas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (VIH/SIDA, trasplantados de órganos sólidos, células hematopoyéticas, neoplasias sólidas y hematológicas, bajo tratamiento quimioterápico o con terapia radiante), diabetes mellitus, obesidad mórbida, fumadores etc.

Actualmente se han reportado casos clínicos en pacientes sin comorbilidades, con cuadros denominados Síndromes inflamatorios sistémicos, con manifestaciones similares a Enfermedad de Kawasaki, pero con formas clínicas graves con shock tóxico, insuficiencia cardiorrespiratoria y necesidad de ingreso a Unidades de Cuidados

Intensivos, producto de una gran liberación de citokinas proinflamatorias desencadenada por el virus SARS CoV 2 que actuaría como un superantígeno.

Para el diagnóstico es muy importante la anamnesis clínica epidemiológica exhaustiva, indagando sobre el contacto con personas confirmadas o sospechosas, antecedente de viajes o contacto con viajeros que hayan estado en contacto con casos sospechosos o confirmados, provenientes del sudeste asiático, Europa, América del Norte y Sur, aunque este dato epidemiológico si bien es importante, actualmente no tiene tanta relevancia, debido a que actualmente la enfermedad es pandémica y en Argentina está demostrada hace meses la transmisión local en la comunidad.

Se han confeccionado definiciones de casos sospechosos para la Población en General y para el Personal de Salud, que debido a la poca experiencia que contamos los profesionales a cargo, por ser una enfermedad emergente estas mismas son dinámicas y cambiantes día a día, por lo que solamente abordaremos la definición de Caso Sospechoso en la Población General, sobre todo pediátrica.

Caso sospechoso de Infección por SARS CoV2 (20 de Mayo de 2020)

- Toda persona que presente fiebre (37,5 °C o más) y
- Uno o más de los siguientes síntomas
 - Tos
 - Odinofagia
 - Dificultad Respiratoria
 - Anosmia/disgeusia de reciente aparición
 - Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica
- Y
- En los últimos 14 días tenga un historial de viaje fuera del país
- Ó
- Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina

Tratamiento

Es sintomático y de sostén, oxigenoterapia de requerirse hasta ARM.

No existen a la fecha y sobre todo en pediatría,

tratamientos específicos.

Se han realizado Protocolos con series muy pequeñas de pacientes con Cloroquina, Hidroxicloroquina (actualmente suspendidos por ser inefectivos y tóxicos, con efectos adversos graves), antirretrovirales (Lopinavir/ritonavir, Remdesivir por vía endovenosa), Interferón Alfa, Ibuprofeno nebulizado todos con resultados poco alentadores y controversiales, por lo que se deben hacer ensayos bien diseñados bajo Protocolos de Investigación, con series de pacientes más grandes para poder evaluar la efectividad de los mismos.

Actualmente el Plasma Inmune de Convaleciente ha demostrado ser eficaz para mejorar los síntomas y la evolución clínica, existiendo actualmente disponibilidad para su uso en pacientes graves y gravísimos, bajo Protocolo de Investigación Clínica, aprobado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Medidas de prevención

Actualmente no se cuenta con vacunas. Se están ensayando tratamientos preventivos

Las medidas de prevención más importantes son:

- Mantener la distancia social de 2 metros
- Uno de tapabocas-tapanariz o barbijos
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución alcohólica en gel
- Evitar tocarse boca, nariz y ojos (Zona T)
- Evitar las reuniones sociales y aglomeraciones de personas, contacto con superficies y fómites que puedan estar contaminados
- Medidas de saneamiento ambiental-agua potable

Para los trabajadores de salud a estas medidas de prevención se debe agregar los Elementos de Protección personal (EEP), que serán aplicados para la asistencia de todos los pacientes, con mayor protección ante sujetos que cumplan con criterio de caso sospechoso y se deba realizar procedimientos que puedan generar riesgo de contagio: examen físico, mediante el uso de EPP 2 (camisolín común, barbijo quirúrgico, antiparras, guantes, botas)

En caso de tener que realizar toma de muestras de hisopado o aspirado nasofaríngeo, hisopado faucial, extracción de muestras de sangre,

instrumentación de la vía aérea, y procedimientos que generen aerosolización como boleo manual con bolsa Ambú con filtros virales, Intubación orotraqueal, nebulizaciones, uso de terapia de alto flujo, ARM se utilizarán EEP 3 (camisolín hidrohonorrepelente, barbijo de alta seguridad N95, antiparras, cofia, guantes, botas y escafandra).

SITUACIÓN CLÍNICA

El caso clínico nos muestra una niña de 6 años que ingresa al Servicio de Emergencias del Hospital de Niños de La Plata y en la evaluación inicial se constata que la paciente presentaba dos criterios de caso sospechoso (fiebre y odinofagia), y un síndrome convulsivo con antecedente de patología infecciosa prenatal (toxoplasmosis congénita controlada y epilepsia tratada con anticonvulsivantes).

Se decide internación en Sala de Terapia Intermedia con aislamiento y se solicita por reunir criterios de caso sospechoso, hisopado nasofaríngeo y realización de Panel de Virus respiratorios que resultó negativo.

La PCR RT para SARS CoV 2 (COVID-19) arrojó un resultado positivo.

La niña evolucionó favorablemente, encontrándose afebril luego de 24 horas de ingresada, lúcida, reactiva, sin requerimientos de oxígeno y sin repetición de episodios convulsivos, con recuperación clínica total. Se repitieron a los 14 días, dos muestras de PCR RT de control para SARS CoV 2 (COVID-19), siendo las mismas negativas por lo cual recibió el alta para continuar con el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno Nacional.

De la anamnesis exhaustiva retrospectiva surge que tanto el padre como su madre no habían cumplido en forma adecuada el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, siendo probablemente uno de los dos progenitores que estaban asintomáticos la fuente de contagio de la niña.

Como conclusión se destaca lo inespecífico y proteiforme de las formas de presentación clínica que pueden simular otras entidades clínicas, incluyendo desde formas asintomáticas, pasando por formas leves-moderadas a graves y gravísimas, por lo que es de fundamental im-

portancia la anamnesis clínico epidemiológica exhaustiva, la sospecha diagnóstica, a través de la definición de caso sospechoso (con su adecuada actualización al momento del diagnóstico), sumado a la noción de procedencia de un área con importante transmisión comunitaria, o de contacto con casos sospechosos luego confirmados, teniendo en cuenta que con el devenir de la Pandemia pueden aparecer otras formas clínicas de presentación, que se irán agregando a las formas de presentación actuales más frecuentes, teniendo presente que la Infección por SARS CoV 2, puede convertirse en “la Gran Simuladora”, lo que implique que el Personal de Salud frente a todo paciente debe actuar y protegerse para sí, por el resto de sus compañeros de trabajo y otros pacientes con los cuales esté en contacto, pensando siempre que el paciente que está evaluando puede tener una Infección por SARS CoV 2.

Bibliografía

Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Consenso del Comité Asesor para temas sobre COVID-19 del Ministerio de Salud de la PBA sobre Diagnóstico y Vigilancia. (29 de abril de 2020).

Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Protocolo de Preparación para la respuesta ante la contingencia de Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID 19) Sector Público- Privado-Seguridad Social (actualizado al 18 de mayo de 2020).

Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Procedimientos de actuación para la prevención y control de casos de COVID-19 en el Personal de Salud. Información actualizada al 19/05/20.

Saxena SK. Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19). *Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Therapeutics*. Ed Springer.

Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus Infections in Children including COVID-19. An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children. *Pediatr Infect Dis J* 2020; 39: 355-368.

*Dr. Juan Carlos Daniel Morales

Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas “Prof. Dr. Emilio Cecchini”, Hospital de Niños Superiora “Sor María Ludovica” de La Plata.

**Dra. Cecilia Vinuesa

Médica de Planta Servicio de Enfermedades Infecciosas “Prof. Dr. Emilio Cecchini”, Hospital de Niños Superiora “Sor María Ludovica” de La Plata.

ARRITMIAS EN PEDIATRÍA



DR. JORGE BLEIZ*

Sumario

El término arritmia o disrritmia cardíaca es usado para cualquier alteración del ritmo cardíaco. Se manifestará por una alteración del patrón normal de los latidos cardíacos, el cual puede ser lento (bradiarritmia), acelerado (taquiarritmia), prematuro (extrasístole), retrasado (escape) o irregular (fibrilación auricular). Un análisis para el diagnóstico y la derivación oportuna.

Introducción

Clasificación de las arritmias cardíacas

Una clasificación es la basada en los mecanismos electrofisiológicos implicados, y es la siguiente:

- Arritmias causadas por alteración en la formación del impulso cardíaco (automatismos):
 - » Automatismo fisiológico alterado (originado en fibras especializadas):
 - Aumentado
 - Deprimido
 - » Automatismo anormal (originado en fibras auriculares o ventriculares comunes)
 - » Automatismo desencadenado (actividad gatillada o postdespolarizaciones):
 - Postdespolarizaciones tempranas
 - Postdespolarizaciones tardías
- Arritmias causadas por alteración en la conducción del impulso cardíaco
 - » Bloqueos:
 - Aurículo-ventriculares
 - Intra-auriculares
 - Intraventriculares

Reentrada:

- » Según las características anatómicas

- Macroreentrada
- Microreentrada
 - » Según las propiedades intrínsecas
- Reentrada anatómica
- Reentrada funcional
- Reentrada anisotrópica
- Reflexión
- Sumación
- Inhibición
- Arritmias causadas por alteraciones mixtas (automatismo más reentrada).
- Arritmias causadas por marcapasos.

De acuerdo a su comportamiento clínico las arritmias se clasifican en benignas y malignas.

Las benignas generalmente son asintomáticas, no provocan alteraciones hemodinámicas y no implican riesgo, sin requerir tratamiento ni seguimiento alguno. Dentro de ellas encontramos la arritmia sinusal, el marcapasos auricular migratriz, el ritmo de la unión aurículo-ventricular (A-V), y las extrasístoles auriculares y ventriculares.

Las arritmias malignas tienen un espectro clínico variable, siendo sintomáticas y comprometiéndolo el estado circulatorio del paciente en un extremo, pero con otro extremo donde podríamos llamarlas potencialmente malignas, ya que no hay compromiso inicialmente, pero ciertas condiciones asociadas (edad del paciente, frecuencia cardíaca durante el episodio, cardiopatía subyacente, patologías clínicas) le imponen un riesgo que requieren de una exhaustiva evaluación y tratamiento oportuno. En este grupo mencionaremos las taquicardias supraventriculares.

culares (TSV) paroxísticas y no paroxísticas, el bloqueo A-V completo congénito, y el síndrome del intervalo QT prolongado congénito y el adquirido⁵.

Dentro de las TSV no paroxísticas se encuentra la taquicardia sinusal, que es la más frecuente en la edad pediátrica, apareciendo en situaciones fisiológicas o patológicas (ejercicio, fiebre, hipoxia, anemia, deshidratación, hipovolemia, hipertiroidismo, etc.) y que responde al tratamiento de la situación de base que la desencadenó. En orden de frecuencia le sigue la TSV paroxística, que se presenta en forma súbita, requiriendo tratamiento específico para su terminación.

Taquicardia Supraventricular

Definición

Taquicardia con complejo QRS angosto (duración <80 milisegundos) generalmente, originada por encima de la bifurcación del haz de His. Si bien esta definición es muy útil, al momento de tratarlas es conveniente tener en mente un enfoque fisiopatológico, con lo cual podríamos dividir las en dos grupos:

1. Aquellas donde la participación del nódulo auriculoventricular (NAV) es fundamental (componente crítico) para que la taquicardia se perpetúe. Son las llamadas TSV paroxísticas, donde cualquier tratamiento (maniobras vagales, adenosina) que actúe a nivel del NAV las interrumpe (además de un componente crítico, el NAV es un parámetro vulnerable).

2. Aquellas que no requieren de la participación del NAV para perpetuarse. Son las llamadas taquicardias auriculares primarias (TAP) donde las acciones a nivel del NAV sólo son una herramienta diagnóstica (aquí no es un componente crítico ni un parámetro vulnerable) pues al bloquearse transitoriamente el pasaje AV de impulsos pone en evidencia lo que ocurre a nivel auricular⁷.

En la siguiente tabla se comparan los dos mecanismos principales, que tienen un comportamiento diferente, lo cual nos ayudará para enfocar la arritmia en la cabecera de la cama.

Manifestaciones clínicas

• TSV paroxísticas:

Generalmente son corazones sanos. Tienen una edad de presentación con tendencia bimo-

dal, con un pico en recién nacidos/lactantes, y otro en la preadolescencia. Responde al mecanismo de reentrada, con una vía accesoria generalmente (80%) como parte del circuito de reentrada (macroreentrada), que conecta la aurícula con el ventrículo correspondiente. Otro mecanismo de reentrada, pero mucho menos frecuente, es la reentrada en el NAV (microreentrada), donde éste presenta una disociación en dos vías (una lenta y otra rápida). En la macroreentrada, el ECG en ritmo sinusal puede denotar la presencia de esa vía (intervalo PR corto, onda delta), conformando así el síndrome de Wolff-Parkinson-White (figura 7), o bien ser completamente normal (vía oculta). En la microreentrada el ECG en ritmo sinusal puede ser normal, o bien presentar por momentos intervalos PR de diferente duración denotando la presencia de las dos vías.

En la macroreentrada, durante la taquicardia, generalmente el impulso eléctrico es conducido hacia los ventrículos a través del sistema de conducción normal (es decir en forma ortodrómica), activa a los mismos simultáneamente, y origina un QRS angosto, y luego asciende por la vía accesoria para reexcitar la aurícula y volver a descender produciendo un movimiento circular.

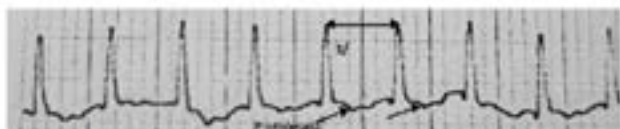
En la microreentrada, lo más frecuente es que el impulso durante la taquicardia descienda por la vía lenta y ascienda por la rápida (reentrada nodal típica). Si ocurre a la inversa, se la denomina reentrada nodal atípica.

En raras ocasiones, ocurre que el impulso conducido normalmente, a alta frecuencia, encuentra a alguna de las ramas del haz de His aún no recuperadas totalmente, con el consiguiente retraso del impulso, produciendo un QRS de mayor duración (TSV con aberrancia, 15 a 30%). Otras veces puede existir un bloqueo de rama previo, lo cual dará también un QRS ancho durante la TSV (TSV con bloqueo de rama). Finalmente,

TRATAMIENTO	AUTOMATISMO	REENTRADA
Maniobras vagales	No responde	No responde
Adenosina	No responde	No responde
Sobrestimulación	No responde	No responde
Cardioversión eléctrica	No responde	No responde
Drogas antiarrítmicas	Respuesta variable	Respuesta variable
Ablación	Indicada en taquicardiomiopatía	Tratamiento curativo

puede ocurrir que el impulso llegue al ventrículo por la vía accesoria y no por el sistema de conducción normal (TSV antidrómica, 5%), donde los ventrículos no se activarán simultáneamente, originando también un QRS ancho. Debemos destacar que ante una taquicardia con QRS ancho, no es conveniente asumir de entrada estas posibilidades, pues lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular.

FIGURA 2.



• Forma de terminación: con una onda P retrógrada en la TSV por reentrada (ya que es la última onda en inscribirse porque el movimiento circular se interrumpe en el NAV).

FIGURA 3.



Análisis electrocardiográfico.

Aporta los datos necesarios para un diagnóstico fisiopatológico y para el tratamiento medicamentoso inicial, permitiendo reservar el estudio electrofisiológico para el tratamiento definitivo (ablación por radiofrecuencia) cuando esté indicado.^{9/10/11}

• Análisis del complejo QRS

Ciclo (tiempo entre cada QRS) de la taquicardia: es siempre regular en las TSV paroxísticas. Es irregular generalmente en las TAP, ya que algunos impulsos pueden bloquearse en el NAV o bien presentar periodos de aceleración y desaceleración (propios de los automatismos).

Alternancia eléctrica: es la presencia de voltaje alternante en los complejos QRS. Ocurre en las TSV por reentrada en una vía accesoria, con bastante especificidad.

Aparición de **bloqueo de rama durante la taquicardia**, con enlentecimiento de la misma: indica que hay una vía accesoria ubicada del mismo lado de la rama bloqueada (Ej.: bloqueo de rama derecha, vía del lado derecho)

• Onda P

No visible: reentrada nodal típica generalmente (rara vez se trata de una vía accesoria)

Visible, con polaridad normal: taquicardia auricular ectópica (foco cercano al nódulo sinusal), reentrada en el nódulo sinusal, taquicardia sinusal.

Retrógrada (polaridad negativa en derivaciones D2, D3 y aVF): Ubicada en la primera mitad (1/2 de figura 2) del ciclo RR: reentrada nodal típica, reentrada ortodrómica en vía accesoria.

Ubicada en la segunda mitad (1/2 de figura 3) del ciclo RR: reentrada nodal atípica, taquicardia auricular ectópica (con foco cercano al nódulo AV), taquicardia reciprocante permanente (tipo Coumel).

• Taquicardias auriculares primarias (TAP) (figuras 4, 5 y 6)

No son importantes por su frecuencia de ocurrencia (10-15%) sino por su mayor morbilidad relacionada a su difícil manejo. Se dan tanto en corazones sanos como en patológicos, a cualquier edad, y aunque pueden ser paroxísticas, generalmente tienden a la cronicidad. El mecanismo puede ser una reentrada (aleteo auricular, fibrilación auricular, reentrada en el nódulo sinusal) o un automatismo (taquicardia auricular ectópica, taquicardia auricular multifocal).

Anamnesis.

Edad de comienzo de los síntomas (a menor edad menor riesgo de recidivas después del año). Antecedentes perinatales (asfixia, secuela neurológica). Antecedentes de interurrencias recientes (respiratoria, infecciosa). Historia familiar de arritmias, o antecedentes personales de cardiopatía congénita o adquirida (aproximadamente un 30%). Terapéutica que recibió en los últimos meses (simpaticomiméticos, diuréticos, antiarrítmicos). Disnea. Palpitaciones.^{12/13/14}

Examen físico.

Facie. Forma del tórax y presencia de cicatrices (mayor incidencia de arritmias auriculares luego de ciertas técnicas quirúrgicas: Senning, Mustard, Fontan). Presencia de soplos cardíacos (la enfermedad de Ebstein y la transposición corregida de los grandes vasos se asocian frecuentemente con síndrome de WPW). Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ritmo diurético, tensión arterial, ritmo de galope, hepatoesplenomegalia (para evaluar estado hemodinámico, alterado en un tercio de los pacientes, preferentemente lactantes).¹⁵

Criterios de internación.

Todos los pacientes deben ser internados durante el episodio agudo.

Laboratorio

Hemograma completo. Hormonas tiroideas. Ionograma plasmático y urinario. Gases en sangre. Urea y creatinina

Tratamiento

Hay que considerar dos aspectos: tratamiento agudo y prevención de recurrencias.

Tratamiento agudo: consiste en la terminación (o bien en el control de la FC usando drogas¹⁶, principalmente en las TAP) del episodio de TSV,

evaluando el estado hemodinámico del paciente:

Si hay estabilidad hemodinámica:

Agua fría (ideal en RN y lactantes): Colocar una compresa mojada con agua fría (5°C) en el rostro del paciente durante 6 a 7 segundos. Se puede repetir hasta tres veces.^{17/18}

Maniobras vagales: contraindicada la compresión ocular; masaje del seno carotídeo; valsalva.¹⁹

Adenosina: 0,15 mg/kg IV por vía periférica (0,1 mg/kg por vía central) en bolo rápido, seguida de bolo de solución fisiológica. Se puede repetir dosis hasta 0,3 mg/kg, o hasta 6-12 mg total.²⁰

Digoxina: 0,04 mg/kg/día, 1/2 de la dosis al comienzo (en 15 minutos) y luego 1/4 cada 6 hs. Dosis de mantenimiento 0,01 mg/kg /día.^{21/22/23}

Verapamilo 0,1- 0,2 mg/kg IV en 2-3 minutos. Contraindicado en menores de un año, bajo volumen minuto, y terapia betabloqueante previa.²⁴

Esmolol: 0,5 mg/kg IV en 1 minuto. Contraindicado en menores de 1 año.²⁵

Amiodarona: dosis de carga 5 a 10mg/kg IV, diluida en SG5%, infundida en 20 o 30 minutos (o bien 2,5 mg/kg en bolo lento cada 5 minutos hasta completar carga).^{26/27/28}

Si hay inestabilidad hemodinámica:

Cardioversión eléctrica (0.25 a 2joules/Kg). Administrar lidocaína 1 mg/Kg IV si ya se usó digoxina.

Si luego de las maniobras vagales o el uso de adenosina se diagnostica aleteo auricular el tratamiento de elección inicial es la cardioversión eléctrica.

Prevención de recurrencias.

Tratamiento crónico: Si el episodio cede espontáneamente, con muy poca recurrencia, sin compromiso hemodinámico, y sin trazado de WPW en el ECG basal, se puede evitar el uso de medicación crónica.

- Digoxina: 0,01 mg/kg/día VO cada 24 hs. Contraindicada si hay trazado de WPW en el ECG al revertir el episodio agudo. Si bien es usada ampliamente en pediatría, es dudosa su utilidad en la prevención de recurrencias.^{29/30/31}

- Atenolol: 1 a 2 mg/kg/día VO, cada 12 o 24 hs.

- Bloqueantes cálcicos (verapamilo; diltiazem): Contraindicados si hay trazado de WPW en el ECG al revertir el episodio agudo. La dosis VO del verapamilo es de 2 a 8 mg/kg/día cada 6 u 8 hs. No hay recomendaciones acerca de la dosis pediátrica del diltiazem, pero se puede utilizar entre 30 a 120 mg/día fraccionado cada 8 hs.

FIGURA 4.

Taquicardia auricular automática con bloqueo AV (Wenckebach).

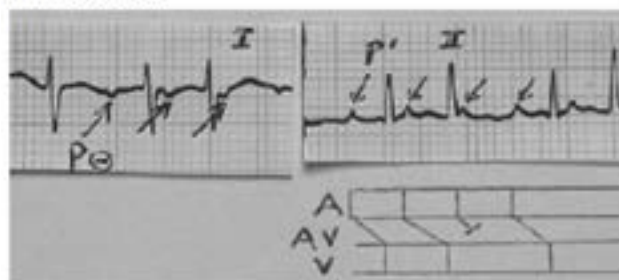


FIGURA 5.

Aleteo auricular con bloqueo AV 4:1.

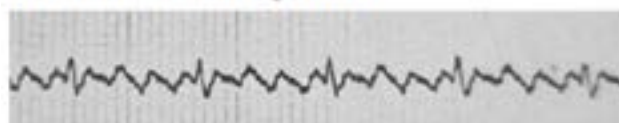


FIGURA 6.

Fibrilación auricular.

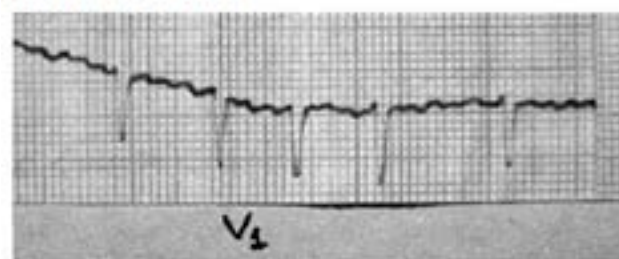
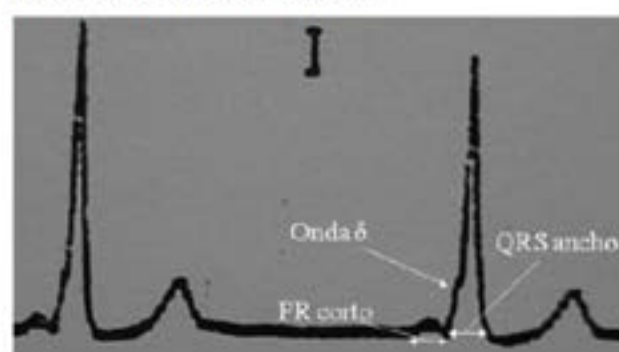


FIGURA 7.

Trazado de Wolff-Parkinson-White.



- Amiodarona: la dosis de mantenimiento VO es de 2 a 5 mg/kg/día, cada 24 hs. Si se requiere dosis de carga VO se realiza a razón de 10-15 mg/kg/día durante 5 a 10 días.^{32 / 33 / 34}

- Flecainida: dosis VO de 2 a 7 mg/kg/día, cada 12 hs.

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Debido a que en un pequeño porcentaje de pacientes con trazado de WPW, la primera mani-

festación clínica puede ser un episodio de muerte súbita, por encima de los 5 años de edad la ablación del haz accesorio por radiofrecuencia está recomendada. Si no hay trazado de WPW (vía oculta), pero persisten sintomáticos a pesar de la terapia farmacológica está indicada la ARF.

Criterios de alta

Superado el episodio agudo y estabilizado el ritmo del paciente.

Controlada la enfermedad actual y/o los trastornos metabólicos.

Instituida la terapéutica de prevención para cada arritmia.

Se determinará el alta previa consulta con cardiología.

Bradiarritmias

Se tratan de ritmos anormalmente lentos, y son la consecuencia de una depresión del automatismo de las células marcapaso o del bloqueo de la conducción del impulso eléctrico. Con valores de FC obtenidos por monitoreo Holter 24 hs podemos definir como bradicardia a una FC menor de 80 l.p.m. en RN y lactantes, menor de 60 l.p.m. entre 2 y 6 años, menor de 45 l.p.m. entre 7 y 11 años, menor de 40 l.p.m. en >12 años, y menor de 30 l.p.m. en atletas.^{35/36}

El gasto cardiaco en RN y niños pequeños está mantenido fundamentalmente por la frecuencia cardiaca, de ahí que los ritmos lentos puedan producir alteración hemodinámica importante.

Las causas principales pueden ser adquiridas o congénitas. Dentro de las adquiridas tenemos la hipoxia, hipotermia, alteraciones de electrolitos, uso de fármacos (digoxina, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, amiodarona), hipervagotonía (aspiración de secreciones, vómito, entrenamiento deportivo), meningitis, hipertensión intracraneal, tumor cervical o del mediastino, mixedema, hipotiroidismo, anorexia nerviosa, sepsis, miocarditis, y el post-operatorio de cirugía cardiaca. Las principales causas congénitas son las colagenopatías maternas, las cardiopatías congénitas, y el síndrome del intervalo QT prolongado.

Tipos de bradiarritmias

Arritmia sinusal

Puede darse como una respuesta normal a la respiración (arritmia sinusal respiratoria) donde

la FC aumenta con la inspiración (inhibición refleja del tono vagal) y disminuye con la espiración, o bien no ser de origen respiratorio (intoxicación por digital, hipertensión endocraneal). La forma respiratoria es benigna y no requiere tratamiento.

Paro sinusal

Se produce una interrupción momentánea de la actividad del nodo sinusal (NS), por lo tanto en el ECG desaparece la onda P y el QRS, apareciendo una línea isoelectrica (pausa) hasta la próxima onda P, o bien si la pausa sinusal es larga puede aparecer un latido de escape, que generalmente es producido por el NAV (se verá un complejo QRS sin ser precedido por la onda P). Los intervalos entre cada onda P no son múltiples.

Bloqueo sinoauricular (SA)

La actividad del NS está conservada. Lo que ocurre es una alteración en la conducción del impulso hacia la aurícula, ocurriendo sólo un retraso (bloqueo SA de 1º grado) o bien la interrupción total de la conducción, siendo en este último caso interrumpida en forma incompleta (bloqueo SA de 2º grado) o completa (bloqueo SA de 3º grado).

Síndrome del seno enfermo

Se caracteriza por una función anormal del NS por alteraciones orgánicas y funcionales, dando como resultado final una alteración en la formación del impulso y/o en su transmisión hacia la aurícula. Pueden ocurrir pausas largas y latidos de escape nodales.

Puede aparecer en el post-operatorio de la cirugía cardíaca por la hipotermia inducida durante la circulación extracorpórea, por trauma mecánico durante la canulación de la aurícula derecha, o bien por lesión de la arteria nutricia del NS.

Otras causas pueden ser: colagenopatías, isquemia miocárdica, amiloidosis, carditis, metástasis, etc.

Bloqueo auriculoventricular (BAV)

Se define como un retraso o interrupción de la conducción entre las aurículas y los ventrículos, es decir que ocurre en la unión aurículo-ventricular.

a) BAV de primer grado.

Solamente ocurre un retraso del paso del impulso, por lo tanto todas las ondas P llegan a los ventrículos con un PR alargado, generando el QRS (despolarización ventricular).

No requiere tratamiento.

b) BAV de segundo grado.

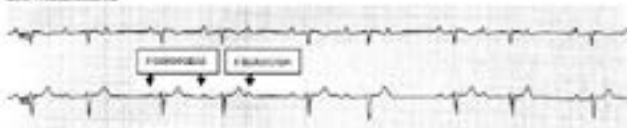
Algunos impulsos son conducidos y otros son bloqueados. Se subdivide en dos tipos:

BAV DE 2º GRADO TIPO I (MOBITZ I O WENCKEBACH): Generalmente se produce a nivel NAV, suele ser transitorio y de pronóstico favorable. Ocurre una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se bloquea por completo un impulso (onda P no es seguida de QRS). Requiere control periódico y rara vez necesita tratamiento.

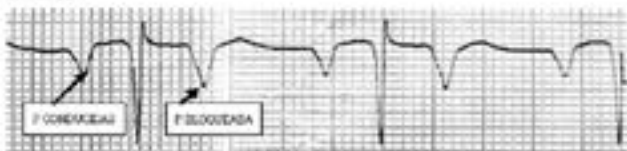
BAV DE 2º GRADO TIPO II O MOBITZ II. Los intervalos PR no se prolongan progresivamente. El impulso auricular deja de conducirse hacia los ventrículos en forma brusca. También se puede controlar periódicamente, pero como su comportamiento es impredecible (más si es post-quirúrgico) generalmente requiere marcapasos cardíaco.

c) BAV DE 3º GRADO O COMPLETO. Interrupción total de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas laten a su ritmo disociadas completamente del ritmo ventricular (ritmo de P mayor que el del QRS). Cuando el BAV ocurre por encima de la bifurcación del haz de His la despolarización ventricular es normal y el QRS será estrecho (ritmo idionodal o escape angosto). Cuando el bloqueo AV está a por debajo de la bifurcación del haz de His el ritmo de escape es ventricular, con QRS ancho, es más lento,

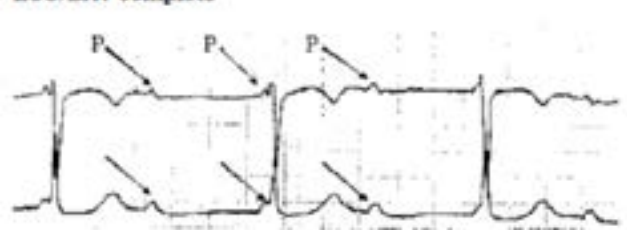
ECG Wenckebach 32



ECG Mobitz II



ECG BAV completo



y se lo llama ritmo idioventricular. Siempre requiere marcapasos cardíaco, siendo el momento oportuno evaluado en base a los datos clínicos y de estudios complementarios.

Bibliografía

-

Aguinaga L. E.; J. Brugada. Seguimiento a largo plazo de pacientes con la forma permanente de taquicardia reciprocante de la unión tipo Coumel tratados con ablación por radiofrecuencia. Edición Latina de Electrocardiología, 1997, Vol. 3, N° 2: 45-52.

Benson. Prediction of digoxin treatment failure in infants with supraventricular tachycardia: role of transesophageal pacing. Pediatrics, 1985, Vol 75, N° 2: 288-293.

Bink-Boelkens. Sinus node dysfunction. Chapter 4, in Cardiac Arrhythmias After Surgery for Congenital Heart disease, S. Balaji and P. C. Gillette, 2001, Arnold.

Campbell R. W. F. Supraventricular tachycardias. Occasional nuisance or frequent threat? Eur Heart J, 1996, Vol. 17, supplement C.

Costigan D. C. Amiodarone therapy effects on childhood thyroid function. Pediatric cardiology, 1986, 77: 703-708.

Cuneo B. F. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of esmolol, a short-acting 6-blocking agent, in children. Pediatric cardiology, 1994, 15: 296-301.

Deal B. J. Supraventricular Tachycardia Mechanisms and Natural History. Chapter 5, in Current Concepts in Diagnosis and management of Arrhythmias in Infants and Children, B. Deal, G. S. Wolff and H. Gelband, 1998, Futura Publishing Company, Inc.

Engel T. R. Effects of digitalis on atrial vulnerability. Am J Cardiol, 1978, Vol 42 : 570-576.

Fish F.; D. W. Benson Jr. Disorders of Cardiac Rhythm and Conduction. Chapter 93, in Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, Moss and Adams, 1995, Williams & Wilkins.

Friedman R. A.. Sinus and Atrioventricular Conduction Disorders. Chapter 4, in Current Concepts in Diagnosis and management of Arrhythmias in Infants and Children, B. Deal, G. S. Wolff and H. Gelband, 1998, Futura Publishing Company, Inc.

Garson A. Jr. Medicolegal problems in the management of cardiac arrhythmias in children. Pediatrics, 1987, Vol 59, N° 1: 84-88.

Gikonyo B. M. Cardiovascular collapse in infants: association with paroxysmal atrial tachycardia. Pediatrics, 1985, Vol 76, N° 6: 922-926.

Gomes J. A. C. Effects of digitalis on ventricular myocardial and His-Purkinje refractoriness and reentry in man. Am J Cardiol, 1978, Vol 42 : 931-938.

Harrison D. C. Antiarrhythmic drug classification: new science and practical applications. Am J Cardiol, 1985, Vol 56 : 185-187.

Johnson G. L. Complications associated with digoxin therapy in low-birth weight infants. Pediatrics, 1982, Vol 69, N° 4: 463-465.

Josephson M. E.; V. H. Schibgilla. Non-pharmacological treatment of supraventricular tachycardias. Eur Heart J, 1996, Vol. 17, supplement C.

Lindsay L. Digoxin inactivation by the gut flora in infancy and childhood. Pediatrics, 1987, Vol 79, N° 4: 544-548.

Lundberg A. Paroxysmal atrial tachycardia in infancy: long-term follow-up study of 49 subjects. Pediatrics, 1982, Vol 70, N° 4: 638-642.

Overholt E. D. Usefulness of adenosine for arrhythmias in infants and children. Am J Cardiol, 1988, Vol 61 : 336-340.

Paul; P. Guccione. New antiarrhythmic drugs in pediatric use: amiodarone. Pediatric cardiology, 1994, 15: 132-138.

Perry. Pharmacologic Therapy of Arrhythmias. Chapter 10, in Current Concepts in Diagnosis and management of Arrhythmias in Infants and Children, B. Deal, G. S. Wolff and H. Gelband, 1998, Futura Publishing Company, Inc.

Pongiglione G.. Use of amiodarone for short-term and adjuvant therapy in young patients. Am J Cardiol, 1991, Vol 68 : 603-608.

Riva S. *Análisis de las alteraciones del segmento ST durante la taquicardia para el diagnóstico diferencial de la taquicardia supraventricular con QRS angosto. Edición Latina de Electrocardiología, 1997, Vol. 3, N° 2: 60-64.*

Shahar E.. *Amiodarone in control of sustained tachyarrhythmias in children with Wolf-Parkinson-White Syndrome. Pediatrics, 1983, Vol 72, N° 6: 813-818.*

Siberbach. *Effect of intravenous propranolol or verapamil on infant orthodromic reciprocating tachycardia. Am J Cardiol, 1989, Vol 63 : 438-442.*

Smith T. W.. *Treatment of life-threatening digitalis intoxication with digoxin-specific Fab antibody fragments. N Engl J Med., 1982, 307: 1387-62.*

Smith W. M. *Long-term tolerance of amiodarone treatment for cardiac arrhythmias. Am J Cardiol, 1986, Vol 57 : 1288-96.*

Sokoloski M. C. *Tachyarrhythmias Confined to the Atrium. Chapter 6, in Clinical Pediatric Arrhythmias, P. C. Gillette and A. Garson Jr., 1999, B. W. Saunders Company.*

Soult J. A. *Efficacy and safety of intravenous amiodarone for short-term treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia in children. Pediatric cardiology, 1995, 16: 16-19.*

Sperandello. *Supraventricular tachycardia in infants: use of the "diving reflex". Am J Cardiol, 1983, Vol 51: 286-287.*

Walsh E. P.; J. P. Saul. *Arritmias cardíacas. Cap. 27, en Nadas Cardiología Pediátrica, 1994, Mosby.*

Watanabe Y.; L. S. Dreifus. *Arritmias Cardíacas. 1979, Ed. Panamericana.*

Waxman M. B.; R. W. Wald. *Vagal techniques for termination of paroxysmal supraventricular tachycardia. Am J Cardiol, 1980, Vol 46 : 655-654.*

Wellens H. J. J. *The value of the ECG in the diagnosis of supraventricular tachycardias. Eur Heart J, 1996, Vol. 17, supplement C.*

Zales V. R.; A Dunningan. *Clinical and electrophysiologic features of fetal and neonatal paroxysmal atrial tachycardia resulting in congestive heart failure. Am J Cardiol, 1988, Vol 62 : 225-228.*

***Dr. Jorge Bleiz**

Ex Jefe del Servicio de Cardiología. Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata.

ENFERMEDADES TIROIDEAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA



DRA. ZULMA CRISTINA SANTUCCI*

Sumario

Postrer homenaje a una compañera de la mejor calidad humana y académica. En ese artículo, publicado en el Portal de Educación Permanente en Pediatría, resume magistralmente las enfermedades tiroideas en la infancia y adolescencia para una rápida presunción de todos los que atendemos niños en escenarios variados. **Gracias por siempre, Zulma. Dr. Juan Reichenbach.**

Introducción

El prolongado proceso de crecimiento y desarrollo que caracteriza la infancia y la pubertad del hombre, justifica la existencia de la pediatría como una especialidad diferente de la clínica general. Las enfermedades de estas etapas tienen distinta expresión clínica y consecuencias que en el adulto, ya que involucran a un individuo en crecimiento. Las hormonas tiroideas cumplen un rol fundamental en este proceso, con especial participación en algunos períodos críticos. La alteración del eje tirotrófico durante la etapa infanto-juvenil puede provocar alteraciones de diferente gravedad, con secuelas irreversibles si el cuadro no es reconocido y tratado oportunamente.

Objetivos

Brindar al pediatra los elementos que le permitan:

- Reconocer los signos de sospecha de las enfermedades más frecuentes de la glándula tiroides en la infancia y adolescencia.

- Establecer el grado de urgencia que cada una de las enfermedades implican.
- Diseñar estrategias para prevenir las secuelas.

Para comprender las enfermedades de la glándula tiroides en relación a su etiología, consecuencias clínicas, métodos de estudio y tratamientos, es conveniente recordar algunos conceptos de su embriogénesis, histología, funcionamiento y mecanismos de regulación funcional. Así el abordaje se dividirá en una primera parte, destinada a una breve exposición sobre estos procesos y una segunda parte en la que se describirán las enfermedades tiroideas.

Primera parte

1 - Embriología

La tiroides es la primera glándula endócrina que aparece durante el desarrollo embrionario. Se la puede identificar a los 16-17 días de gestación como un esbozo endodérmico medial en la cara ventral de la faringe, entre los arcos branquiales 1 y 2. En su proceso de proliferación y diferenciación celular este divertículo tiroideo se profundiza ventralmente en el mesénquima mesobranquial, manteniéndose en continuidad con el epitelio del piso faríngeo por un pedículo llamado conducto tirogloso. Este conducto se oblitera en estadios posteriores del desarrollo para luego desaparecer. Su primitivo punto de invaginación en el vértice de la “V” lingual se conoce como agujero ciego lingual. Una parte del conducto tirogloso puede per-

sistir y mantenerse permeable en cualquier altura de su trayecto, originando el quiste tirogloso. En el proceso de descenso, el esbozo tiroideo termina ubicándose en la base del cuello hacia los 40-50 días de gestación y se expande lateralmente para adquirir su estructura bilobulada característica. Los eventos críticos de la morfogénesis de la glándula tiroidea se llevan a cabo durante los 2 primeros meses de la gestación. Por lo tanto la mayoría de sus alteraciones estructurales -agenesia o disgenesia- dependen de complicaciones ocurridas durante esa etapa. Se han descrito alteraciones genéticas responsables de estos cuadros. La glándula tiroidea ectópica por ejemplo, resulta de una anormal migración del esbozo medial que no completa su proceso de descenso y desarrollo, pudiendo localizarse en el dorso de la lengua, en la zona sublingual, en regiones altas del cuello o en el mediastino (ver Figura 1). En la embriogénesis normal, esbozos laterales originados en la 4ta. y 5ta. bolsa faríngea -con elementos procedentes de la cresta neural- se unen al referido esbozo impar y medio hacia la 8 o 9 semanas de gestación, adquiriendo así la glándula tiroidea su forma definitiva. Estos aportarían las células parafoliculares productoras de calcitonina. La tiroidea al igual que los testículos constituyen, por su tamaño y ubicación, las únicas glándulas endócrinas que pueden explorarse por palpación.

2 - Histología

La glándula tiroidea está constituida por una agrupación de folículos. Cada uno de ellos representa una unidad funcional y sus células, distribuidas en una capa única, tienen una cara apical orientada hacia la cavidad central con contenido coloide y una cara basal en contacto con los capilares sanguíneos (Figura 2). El coloide constituye el reservorio de la tiroglobulina (Tg), que es la proteína específica producida por la célula tiroidea. Esta constituye la matriz en la que se van a sintetizar y almacenar las hormonas tiroideas hasta su liberación. También pueden identificarse células parafoliculares.

3 - Biosíntesis de las hormonas tiroideas y su liberación a la circulación general

Las células parafoliculares de la glándula tiroidea producen calcitonina que es una hormona vinculada con el metabolismo fosfocálcico. Las

foliculares o tirocitos sintetizan triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) mediante un complejo mecanismo. Estas dos últimas hormonas una vez liberadas a la circulación general, son transportadas por proteínas específicas hasta los tejidos donde ejercen su acción metabólica. En este proceso de biosíntesis y liberación hormonal ocurren una serie de pasos que se describen sintéticamente a continuación (ver Figura 2).

a) Incorporación del yodo a la glándula tiroidea. El yodo es el elemento fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas e ingresa al organismo con los alimentos y el agua. Los requerimientos diarios de yodo son escasos, pero si la ingesta se mantiene en niveles muy bajos por mucho tiempo puede ocurrir una disminución de la síntesis hormonal. Los tirocitos tienen capacidad para concentrar el yodo, almacenarlo (en la Tg) y regular su liberación y secreción como hormona activa, según las necesidades del organismo. Las células tiroideas no diferencian entre el yodo natural y sus isótopos radioactivos. Por eso estos últimos se usan para realizar estudios funcionales de la glándula o con fines terapéuticos para destruir tejidos tiroideos hiperfuncionantes o metástasis de tumores tiroideos diferenciados. También se puede utilizar el tecnecio 99 para identificar la presencia de tejido tiroideo, porque es semejante al yodo en su carga iónica y en su volumen. Cuando el mecanismo de captación del yodo está genéticamente alterado, los pacientes desarrollan hipotiroidismo y bocio.

b) Síntesis de tiroglobulina. La Tg es una glicoproteína que se sintetiza en los ribosomas de los tirocitos, para luego ser empaquetada en vesículas a nivel del aparato de Golgi y vertida finalmente a la luz folicular. Todo este proceso es controlado por la tirotrófina hipofisaria (TSH). Los defectos congénitos en la síntesis de Tg complican el proceso de la hormonogénesis, por lo que los individuos desarrollan hipotiroidismo.

c) Incorporación del yodo a las tiroglobulinas. En la interfase membrana apical-coloide, el yodo se une a los tirosilos de la Tg en un proceso catalizado por una peroxidasa. Se constituyen así las monoyodotirosinas (MIT) y las diyodotirosinas (DIT). Por reacciones de acoplamiento entre estos compuestos se forman las hormonas tiroideas propiamente dichas: los residuos triyodotironínicos (T3) y tetrayodotironínicos (T4), los

que quedan incorporados a la molécula de Tg. Existen sustancias sintéticas o naturales y defectos genéticos, que interfieren en este proceso de organificación del yodo. Este fenómeno es utilizado como un recurso terapéutico en cuadros de hiperfunción tiroidea como en el caso del metimazol o puede generar cuadros de hipotiroidismo.

d) Liberación de las Hormonas Tiroideas. La Tg yodada -reserva de T3, de T4 y de yodo- se almacena en el coloide. Cuando el tirocito es estimulado por la TSH se engloban pequeñas porciones de coloide desde la luz folicular hacia el citoplasma, donde los lisosomas fagocitan la envoltura de las vesículas y las proteasas liberan todos los aminoácidos yodados: MIT, DIT, T3 y T4. Las hormonas tiroideas pasan a la sangre y los residuos MIT y DIT son desyodados, reutilizándose a partir de ellos el yodo mediante una nueva incorporación a otra molécula de Tg. Defectos congénitos en estas desyodinasas impiden la reutilización descrita, por lo que el yodo se pierde por la orina y en áreas con baja ingesta de yodo puede aparecer hipotiroidismo.

4 - Transporte

La T4 y la T3 circulan en la sangre en parte como aminoácidos libres y en parte unidas a proteínas específicas, siendo la TBG (thyroxine-binding globulin) la más importante por ser la de mayor afinidad. Las cifras circulantes de TBG pueden estar aumentadas o disminuidas por diferentes situaciones lo que a su vez aumenta o disminuye los valores totales de las hormonas tiroideas circulantes, con mantenimiento de la fracción libre lo que preserva el eutiroidismo. Los valores de T3 y T4, tanto libres como totales, disminuyen lenta y progresivamente con la edad. Son las formas libres las que ingresan a las células para ejercer su acción.

5 - Mecanismos de acción de las hormonas tiroideas

La T4 es una prohormona que debe desyodarse a T3 para fijarse a los receptores nucleares de las células y ejercer su acción. Las reacciones de desyodinación no ocurren al azar. Se conocen tres desyodinasas que se diferencian por los tejidos en los que predominan, su preferencia de sustrato, requerimiento de cofactores, etc. Las más importantes son la tipo II y la tipo III.

Desyodinasa tipo II: transforma la T4 a T3 y

se encuentra distribuida principalmente en el sistema nervioso central, hígado, riñón y en los tejidos periféricos. La concentración de la desyodinasa tipo II es inversamente proporcional a la concentración de T4. Constituye un mecanismo de protección de los tejidos más lábiles -por ejemplo el sistema nervioso- ante una situación de hipotiroidismo.

Desyodinasa tipo III: inactiva la T3 y la T4 por conversión a sus metabolitos inactivos. La desyodinasa tipo III aumenta cuando hay un exceso de concentración de T4 en los tejidos. Constituye un mecanismo de protección contra el hipertiroidismo.

Las hormonas tiroideas producen sus efectos biológicos controlando la expresión de los genes sensibles a ellas. Las fracciones libres ingresan al citoplasma celular donde la T4 es desyodada para originar T3. Esta es trasladada de manera activa al núcleo celular donde se une a los receptores específicos y ejerce su acción.

6 - Acciones de las hormonas tiroideas

La T3 acelera la transcripción del ADN con formación del ARN mensajero y ribosómico activando así la síntesis proteica, actúa sobre las mitocondrias favoreciendo los mecanismos de transporte de electrones en la cadena respiratoria para la formación de ATP, y sobre diversas etapas del metabolismo hidrocarbonado, de los lípidos y de las vitaminas. Los receptores de las hormonas tiroideas están ampliamente distribuidos en todo el organismo. Las hormonas tiroideas cumplen un papel relevante en los procesos metabólicos básicos y por ello las condiciones de exceso o déficit hormonal se expresan con una repercusión tan florida sobre toda la economía. Participan así en los procesos de crecimiento y desarrollo de todos los tejidos. A nivel neurológico intervienen en la gliogénesis, en la mielinización y desarrollo de las sinapsis interneuronales y en los procesos de proliferación y diferenciación celular. De esta manera se explica el profundo daño neurológico irreversible que padecen los niños con hipotiroidismo durante los primeros 24-36 meses de la vida, por tratarse de una etapa crítica para el crecimiento y desarrollo de ese tejido. El crecimiento y la maduración del tejido óseo son marcadamente dependientes de las hormonas tiroideas. El enlentecimiento del crecimiento durante la infancia es uno de los indicadores que obliga

a la investigación del hipotiroidismo entre sus causas etiológicas posibles. A nivel hepático influye sobre la actividad de sus enzimas. Los RN con hipotiroidismo suelen presentar ictericia indirecta prolongada. Cumplen también un rol importante sobre la termogénesis, sobre la secreción y acción de la hormona de crecimiento, sobre la síntesis y secreción de diversas otras hormonas y sobre la regulación del número de receptores para las acciones de las mismas.

7 - Regulación de la función tiroidea

La biosíntesis de las hormonas tiroideas es controlada por complejos mecanismos extrínsecos -eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo- e intrínsecos o autorreguladores llevados a cabo por la propia glándula tiroides. En una apretada síntesis, los hechos más sobresalientes se pueden esquematizar de la siguiente manera.

a) Síntesis, secreción y acción de la TSH. La TSH es una glicoproteína que se sintetiza y secreta en las células tirotropas de la hipófisis, lo que a su vez es modulado por la hormona hipotálamica liberadora de tirotrófina (TRH). Ejerce su acción uniéndose a su receptor específico en la membrana basal del tirocito. Estimula así la captación de yodo y la síntesis de Tg, su yodación y las reacciones de acoplamiento, la endocitosis de la Tg yodada y su proteólisis, y finalmente la liberación de las hormonas tiroideas. Si la estimulación de la glándula tiroides por la TSH se mantiene de manera crónica con niveles superiores a los normales, se produce finalmente una hiperplasia glandular y bocio.

b) Mecanismo de retroalimentación negativa. La secreción central de TSH y TRH aumenta o disminuye en respuesta a concentraciones disminuidas o aumentadas de las hormonas tiroideas en la circulación general (ver Figura 3). El responsable de controlar a nivel central este mecanismo es la T3 proveniente de la desyodación local en hipotálamo o hipófisis de la T4. Su aumento frena la secreción de TSH y por el contrario su disminución estimula su síntesis y secreción. Por este origen central de la T3, los valores de TSH se vinculan con las cifras circulantes de T4 y no con las de T3. Esto es de gran interés clínico, porque explica el cuadro bioquímico de valores bajos de T4 acompañados de TSH elevado sin modificación de la T3 circulante, ni signos clínicos de hipotiroidismo. Son estados iniciales de hipofunción, en las que

el diagnóstico resulta un hallazgo idealmente precoz. Estos mecanismos sirven para poner en marcha una respuesta compensadora de la glándula tiroides, en su intento por normalizar los valores de las hormonas periféricas. De esto surge el concepto de que la hormona más sensible para presumir una hipofunción de la glándula tiroides en sus estadios más iniciales es la determinación de TSH. En algunos estados patológicos se producen anticuerpos antirreceptor de TSH, con capacidad para desplazar a la tirotrófina de su sitio de unión específico en el tirocito y ocupar su lugar. Algunos anticuerpos tienen acción estimuladora ocasionando un hipertiroidismo y otros ocupan el lugar de la TSH pero sin capacidad para activar el receptor, por lo que se genera un cuadro de hipotiroidismo. Estos son mecanismos involucrados en las enfermedades inmunológicas que comprometen a la glándula tiroides.

c) Mecanismo de autorregulación de la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene su propio mecanismo de autorregulación destinado a limitar la cantidad de yodo que capta y la cantidad de hormona tiroidea que sintetiza. El objetivo del mismo es controlar la secreción hormonal en situaciones de aumento brusco de la disponibilidad de yodo circulante, tales como la absorción de yodo a través de la piel (antisépticos, bronceadores), ingesta de medicamentos que contengan yodo, exposición a contrastes radio-opacos. En estos casos se deprime la respuesta de las células tiroideas al TSH, disminuyendo así la síntesis de Tg, su yodación y la liberación de hormonas tiroideas. Este efecto se conoce como fenómeno de Wolff-Chaikoff. Una glándula normal es capaz de escapar luego a este efecto inhibitorio y restablecer la producción hormonal en cifras semejantes a las previas al bloqueo. Evita así el hipertiroidismo inicial por exceso de yodo y el hipotiroidismo por mantenimiento prolongado del bloqueo. Existen situaciones fisiológicas como la prematuridad, o patológicas como fallas enzimáticas subclínicas, en las que no funcionan los mecanismos que permiten escapar del efecto Wolff-Chaikoff. En estos casos el contacto con un exceso de yodo puede conducir a hipotiroidismo y bocio.

8 - Función tiroidea en el recién nacido

En los primeros minutos de la vida postnatal se producen una serie de modificaciones fisiológi-

cas en la función tiroidea del RN, como parte de la adaptación al stress que implica el nacimiento.

TSH: aumenta alcanzando sus valores máximos a los 30 minutos del nacimiento (80-100 uU/ml), para descender en los días siguientes llegando a valores inferiores a los 20 uU/ml a las 48 horas de vida. La pesquisa neonatal de hipotiroidismo congénito, en la que se determina el nivel de TSH, se realiza a las 48 horas de vida, porque de esta manera es posible distinguir entre el ascenso fisiológico y el anormal de TSH.

T3 y T4: aumentan acompañando a la TSH, y se mantienen en cifras altas durante el primer mes de vida y aún durante los 2-4 meses siguientes.

El eje tirotrófico en RN prematuros: funciona normalmente, pero los valores de T4 pueden aparecer bajos con TSH normal debido a las cifras bajas de la TBG que normalmente presentan estos niños. No merecen tratamiento y ello se modifica espontáneamente con el crecimiento.

Segunda parte

Las enfermedades de la glándula tiroides se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino. Ante un paciente con enfermedad tiroidea, siempre deben investigarse antecedentes de tiroideopatía en otros miembros de la familia, porque existe predisposición familiar para padecer la misma u otra afección de la glándula.

1 - Alteraciones tiroideas en la etapa neonatal

1.1-RN hijo de madre hipertiroidea. El recién nacido hijo de una madre que ha padecido un hipertiroidismo durante el embarazo generalmente tiene una función tiroidea normal. Pero en su atención deben considerarse las siguientes alteraciones, derivadas tanto de la enfermedad de base de la madre como del tratamiento que ésta haya recibido:

desnutrición: por la disfunción hemodinámica de la placenta producida por la enfermedad materna o por el hipertiroidismo que el feto pudo haber padecido in útero.

hipertiroidismo transitorio: por pasaje transplacentario de ATC tiroestimulantes.

hipotiroidismo transitorio: secundario al metimazol, cuando la dosis fue superior al nivel de seguridad antes referido.

situaciones secuenciales combinadas: de hipotiroidismo secundario al metimazol y hipertiroidismo

por los ATC tiroestimulantes.

craneosinostosis: es poco frecuente, pero tiene graves consecuencias neurológicas.

La duración de los síntomas depende de la vida media del metimazol o de los ATC maternos que circulan ahora en el RN. Los niños que están cursando un hipertiroidismo neonatal pueden presentar exoftalmía, bocio, febrícula, taquicardia, mal progreso de peso, inquietud e hiperorexia. Cuando el hipertiroidismo se mantiene más de lo esperable debe presumirse la presencia de anomalías genéticas activantes del receptor de TSH. El hipertiroidismo neonatal también puede presentarse en los hijos de madres curadas de su hipertiroidismo antes del embarazo mediante la administración de yodo radioactivo. En estos casos, no hay hiperfunción tiroidea en la madre, pero los ATC tiroestimulantes están igualmente presentes en su circulación y pueden atravesar la placenta y ejercer su acción estimulante sobre la tiroides fetal o del RN.

El control del hijo de una madre hipertiroidea debe iniciarse en la etapa prenatal. Una frecuencia cardíaca superior a 160 latidos por minuto en el monitoreo fetal, debe sugerir el diagnóstico de hipertiroidismo y puede requerir intervención terapéutica.

En todo RN hijo de una madre hipertiroidea deben investigarse las disfunciones señaladas y se deben realizar determinaciones séricas de hormonas tiroideas.

Una madre hipertiroidea tratada con 15 y 20 mg/día de metimazol debe mantener su lactancia materna. Esa dosis no provoca disfunción tiroidea en el niño. No obstante éste debe ser controlado periódicamente.

El hipertiroidismo neonatal es una urgencia pediátrica porque pone en riesgo la vida del RN. Su presunción merece consulta especializada, y luego de su confirmación debe recibir tratamiento.

1.2-El RN con hipotiroidismo congénito.

a) Definición de hipotiroidismo: es el cuadro resultante de la insuficiente acción periférica de las hormonas tiroideas.

b) Clasificación: puede estar generado por alteraciones a distintos niveles del eje tirotrófico, originando diferentes formas clínicas con diversos grados de repercusión funcional.

Hipotiroidismo primario: cuando está alterada la glándula tiroides.

Hipotiroidismo secundario: cuando está afectada

tada la secreción de TSH en la hipófisis.

Hipotiroidismo terciario: cuando está comprometida la liberación de TRH en el hipotálamo.

Hipotiroidismo periférico: cuando falla la respuesta de los receptores celulares a las hormonas tiroideas

El hipotiroidismo primario constituye la enfermedad endocrinológica más frecuente de la infancia y por ello será esta forma de hipotiroidismo, la que se describirá en el transcurso de la exposición.

Las formas hipotálamo-hipofisarias son poco frecuentes y generalmente se asocian a otras deficiencias hormonales, siendo éstas las que se destacan y conducen al diagnóstico. Su expresión clínica es más leve que en los primarios y tienen menor riesgo de daño neurológico. La resistencia periférica a las hormonas tiroideas es todavía menos frecuente. A su vez cada una de estas formas de hipotiroidismo, se categorizan de acuerdo al momento de inicio de la enfermedad, de la siguiente manera:

Hipotiroidismo congénito: cuando está pre-

sente desde el nacimiento.

Hipotiroidismo adquirido: cuando se expresa más allá de la etapa neonatal.

El hipotiroidismo congénito primario (HCP) representa la enfermedad tiroidea más relevante de la etapa neonatal, por la gravedad que implica y por su alta frecuencia de presentación.

c) Etiologías: En la Tabla 1 se resumen las principales etiologías.

Las causas más frecuentes de HCP son los defectos estructurales de la glándula: agenesia e hipoplasia tiroidea, ya sea en una glándula ubicada en la región anatómica normal o en algún sitio del trayecto de descenso durante la embriogénesis (ver Embriogénesis de la glándula tiroides). Le siguen los defectos enzimáticos de la síntesis hormonal (ver Biosíntesis de las hormonas tiroideas y su liberación a la circulación general) y con mucha menor presentación las demás etiologías.

d) Presentación clínica. La descripción de los signos clínicos de esta enfermedad debiera ser patrimonio de la historia de la medicina, ya que

Causas de hipotiroidismo congénito	
Primario	
Disgenesia tiroidea	
Atireosis	
Hipoplasia: glándula tiroides ectópica o eutópica	
Bocio dishormonogénico	
Mutaciones inactivantes del receptor de TSH	
Administración de I 131 durante el embarazo.	
Transitorios	
Ingesta materna de antitiroideos	
Ingesta materna de bociógenos o compuestos yodados	
Pasaje de anticuerpos maternos antirreceptor de TSH	
Hipotálamo-hipofisario	
Deficiencias hormonales hipotálamo-hipofisarias múltiples	
Deficiencias hormonales asociadas a defectos anatómicos de la línea media del SNC	
Deficiencia aislada de TRH y de TSH	
Periféricos	
Resistencia periféricas a las hormonas tiroideas	

Tabla 1. Etiologías del hipotiroidismo congénito. Iorcanaky S. modificada

si el tratamiento se instaura en forma precoz y se mantiene adecuadamente, los niños nunca debieran presentar síntomas característicos. La afección es inaparente o presenta signos inespecíficos mínimos durante los primeros días de la vida (Tabla 2), pero librada a su evolución natural, éstos se van acentuando hacia el final del primer mes y en los meses siguientes (Tabla 4).

Los síntomas remarcados son los de presentación más constante.

e) Evolución: es ampliamente conocido entre los pediatras que el HCP en su evolución espontánea lleva a un grave daño neurológico irreversible, acompañado de múltiples disfunciones de casi todos los órganos de la economía. Sin embargo también es cierto que constituye una de las pocas causas prevenibles de retardo mental, si el tratamiento se inicia precozmente. Para lograr este

objetivo, el mismo debe instaurarse lo antes posible, idealmente durante la primera semana de la vida. Cada día de demora en su comienzo, implica un incremento del riesgo de retardo mental. Edad aconsejada para el inicio del tratamiento: antes de los 15 días de vida. El tratamiento revierte los síntomas e impide el ulterior deterioro del SNC, pero no resuelve el daño neurológico ya producido por la enfermedad.

f) Diagnóstico: El inicio oportuno del tratamiento está directamente vinculado con el diagnóstico temprano del HCP. Pero éste no puede basarse solamente en la evaluación clínica, debido a que la gran mayoría de los niños afectados no presentan signos que permitan presumir la enfermedad durante el primer mes de vida o los mismos son bastante inespecíficos.

Signos clínicos	
Facies	Ojos abotagados
	Edema en cara
	Raíz de la nariz hundida
	Macroglosia
Específicos	Bocio
Inespecíficos	Ictericia prolongada
	Hernia umbilical y distensión abdominal
	Fontanela posterior >0.5 cm luego del 7mo. día
	Constipación
	Piel gruesa fría, pálida, seca, moteada por éstasis circulatorio
	Bradycardia
	Hipotermia
	Letargo, motilidad disminuída
	Hipersomnia
	Retardo en la eliminación de meconio
	Llanto ronco y poco vigoroso
	Pelo seco, anemia
	Trastornos de alimentación por hipersomnia

Tabla 2. Signos clínicos de hipotiroidismo congénito en el primer mes de vida. Iorcansky S. modificada.

Con el propósito de arribar al diagnóstico en esta etapa temprana, se iniciaron hace 40 años los primeros programas de pesquisa neonatal de HCP en el mundo. La mayoría de los países fueron incorporando progresivamente esta evaluación para sus RN y han aceptado definitivamente sus incuestionables beneficios.

El diagnóstico del HCP debe formularse tempranamente en ausencia de síntomas y los programas de pesquisa o screening neonatal constituyen el único medio eficaz para alcanzar la detección en esa etapa y su consecuente tratamiento oportuno.

El pediatra debe tener siempre presente que el HCP es una urgencia pediátrica.

Sin embargo no se debe descartar la posibilidad de que un niño padezca la enfermedad por el hecho de contar con un resultado de pesquisa neonatal negativo. Ese resultado sólo confirma que la enfermedad no está presente en el momento en el que la muestra fue tomada, pero existen situaciones en las que el hipotiroidismo puede expresarse más adelante. Por este motivo en algunos países está prevista la reiteración de la evaluación en la 6ta. semana de la vida y en algunos casos como en los hijos de madre hipertiroidea, es conveniente reiterar el estudio en la 2da. semana de la vida.

Si durante el 1er. mes de vida de un RN con evaluación neonatal negativa para HCP aparecieran signos sugestivos de la enfermedad, igualmente se deberán realizar determinaciones séricas de hormonas tiroideas para establecer o descartar el diagnóstico.

La pesquisa neonatal de HCP en la Provincia de Buenos Aires se realiza de manera obligatoria desde 1995 en el marco del Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas (PRODYTEC), implementado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

2 - Alteraciones tiroideas adquiridas

2.1 - Hipotiroidismo adquirido primario (HAP)

El hipotiroidismo puede manifestarse a cualquier edad como un cuadro adquirido, con distinto modo de expresión y consecuencias de acuerdo a la etapa madurativa que esté cursando el niño o el adolescente. Las etiologías también son diferentes en las distintas edades (Tabla 3)

2.1.1 - HAP en los dos primeros años de la vida.

a) Etiología: al igual que en la etapa neonatal, las alteraciones estructurales de la glándula y las fallas enzimáticas siguen siendo en este período las causas más frecuentes.

b) Fisiopatogenia. Las alteraciones referidas generan cuadros congénitos o adquiridos dependiendo de la gravedad del defecto. Cuando el tejido tiroideo es muy pequeño, está ausente o la producción hormonal está muy comprometida, la enfermedad se manifiesta de manera congénita. Cuando por el contrario tiene capacidad para cubrir las necesidades del niño, el eutiroidismo se mantiene por un tiempo variable. Esta situación se extiende hasta que, por el incremento de la superficie corporal, la producción hormonal resulta insuficiente. Ello puede ocurrir durante los primeros meses de la vida o más adelante a los 2, 3 o más años. A partir de

Etiologías
Disgenesias tiroideas
Fallas enzimáticas de expresión tardía
Tiroiditis linfocitarias crónicas
Enfermedades infiltrativas de la glándula tiroidea
Exposición a agentes que deprimen la función tiroidea (fármacos o alimentos)
Ablación tiroidea (quirúrgica, con yodo 131, o radioterapia)

Tabla 3. Etiologías del hipotiroidismo primario adquirido.

entonces la TSH se eleva por encima de lo normal (ver Regulación de la glándula tiroidea) en respuesta a los niveles bajos de hormonas tiroideas circulantes, lo que aumenta el volumen del resto tiroideo tratando de normalizar la función. Así puede aparecer un bocio en algunos pacientes con fallas enzimáticas de la síntesis hormonal, o crecimiento del tejido tiroideo disgenético generando un abultamiento en el dorso de la lengua, en la línea media del cuello o en la base del mismo, según se trate de una tiroides ectópica o de una hipoplasia de la glándula tiroidea ubicada en su lugar anatómico normal. Por lo general los niños con disgenesia tiroidea que expresan la enfermedad en los 2 primeros años de la vida, tienen glándulas demasiado pequeñas y no es posible identificar clínicamente el abultamiento cervical antes referido.

c) Presentación clínica. En esta edad sigue vigente el riesgo de daño irreversible del sistema nervioso central y por eso esta enfermedad debe sospecharse rápidamente después de su comienzo, atendiendo a sus signos mínimos. El más frecuente es: enlentecimiento de la progresión de la talla. Si el cuadro progresa sin tratamiento, los signos y síntomas se manifiestan de un modo solapado e insidioso, agravándose progresivamente en la medida que la situación permanece sin diagnóstico (Tabla 4). Esperar a que el paciente presente los signos característicos de la afección, es sinónimo de llegar tardíamente al tratamiento.

Cuando en un control de salud se detecta un descenso anormal en la progresión de la talla, debe presumirse un hipotiroidismo adquirido entre las etiologías a estudiar. El diagnóstico de las formas adquiridas implica un desafío clínico para el pediatra, ya que la pesquisa neonatal sólo permite investigar las formas congénitas del hipotiroidismo.

d) Evolución. Con el tratamiento los signos se revierten generalmente sin secuela posterior. Sin embargo, si el hipotiroidismo se mantiene sin diagnóstico y consecuente tratamiento durante un tiempo, se produce daño neurológico irreparable.

El diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo es una urgencia durante los 2 primeros años de la vida, porque el período crítico de crecimiento y maduración del sistema nervioso central se extiende hasta esa edad. Lamentablemente no es infrecuente que lleguen a la consulta endo-

Síntomas del hipotiroidismo
Esqueleto
Facies típica por inmadurez
Retraso en el cierre de las fontanelas
Disminución en el crecimiento de los huesos largos
Retardo en la edad ósea y dental
Disgenesia epifisaria
Músculo
Hipotermia
Hipotonía
Aumento en la fase de contracción/decontracción
Pseudohipertrofia muscular
Piel y faneras
Piel fría, pálida, amarillenta, seca y gruesa
Pelo seco. Uñas quebradizas
Mixedema generalizado
Gastrointestinal-hepático
Constipación
Colesterol total y HDL elevados
Cardiovascular
Bradicardia
Anemia
Hipotensión
Disminución de la función renal
Sistema Nervioso Central
Letargo
Hiporreflexia
Atraso en las pautas madurativas

Tabla 4. Signos clínicos de hipotiroidismo. Iorcansky S. modificada

crinológica pacientes con daño neurológico por hipotiroidismo adquirido diagnosticado tardíamente, en los que el pediatra no consideró esta posibilidad apoyándose en el antecedente de una pesquisa neonatal negativa.

2.1.2 - HAP entre los dos y cinco años de edad.

Cuando el cuadro se inicia después de los 2 años, su efecto deletéreo sobre el sistema nervioso central es significativamente menor y en general todos los síntomas son reversibles con el tratamiento.

a) Etiología: en esta etapa las causas más importantes siguen siendo las mismas que en el período anterior.

b) Presentación clínica: En general los niños que logran mantener el eutiroidismo por varios años con estas alteraciones tiroideas, tienen tejido tiroideo de mayor tamaño o con mayor capacidad funcional que los que manifiestan la

disfunción tempranamente. Esto motiva que la hipertrofia glandular se haga visible y suelen llegar a la consulta por alguno de los siguientes signos:

Bulto en la línea media del cuello (Figura 4) o del dorso de la lengua (Figura 5).

Bocio

Enlentecimiento de la progresión de la talla.

Es importante no interpretar la primer situación como un tumor lingual o como un quiste tirogloso, sin realizar los estudios correspondientes. Su resección podría extirpar el único resto tiroideo funcional, con las mismas consecuencias clínicas que una atireosis.

En todo tumor de la línea media del cuello se debe realizar una centellografía con tecnecio o yodo para certificar o descartar la presencia de tejido tiroideo a ese nivel. Si corresponde a una disgenesia tiroidea, concentrará el trazador administrado en la zona de la tumoración y si se trata de un quiste tirogloso, la tiroides se dibujará en su ubicación normal. También puede recurrirse a la realización de una ecografía de la zona. En manos experimentadas podrá visualizarse presencia de tejido tiroideo en su ubicación normal y una imagen quística en la zona del abultamiento, en los casos en que el mismo corresponda a un quiste tirogloso.

c) Evolución. El tratamiento por lo general revierte todos los síntomas sin secuela. Pero si el hipotiroidismo se ha mantenido por un período prolongado deben considerarse dos complicaciones probables:

Deterioro de la talla final como resultado de un crecimiento de recuperación incompleto, después instaurado el tratamiento.

Deterioro de la calidad de vida del niño durante el tiempo en el que se mantuvo el hipotiroidismo sin tratamiento, con sus implicancias psicológicas posteriores.

Sin embargo, lamentablemente siguen llegando pacientes en los que se ha resecado una tiroides disgenética porque fue erróneamente interpretada como un tumor lingual o cervical.

La disgenesia tiroidea no debe resecarse. Su volumen se reducirá una vez instaurado el correspondiente reemplazo hormonal.

2.1.3 - HAP después de los cinco años de edad.

a) Etiología. A partir de esta edad empiezan a aparecer las enfermedades inmunológicas de la

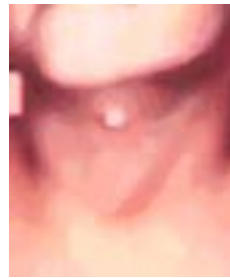


Figura 4. Paciente con tiroides ectópica en la línea media del cuello.



Figura 5. Tiroides ectópica (lingual) ubicada en el dorso de la lengua

glándula tiroides como las etiologías más importantes de los HAP, lo que se acentúa en los años próximos a la pubertad.

b) Fisiopatogenia. En la enfermedad tiroidea de causa inmunológica, están presentes diversos tipos de anticuerpos contra el receptor de TSH con distinta actividad biológica. De acuerdo al tipo de anticuerpos predominantes será la expresión clínica de la enfermedad. Por otra parte, pueden prevalecer unos sobre otros en diferentes momentos evolutivos en un mismo paciente. Por este motivo estas afecciones pueden generar tanto cuadros de hipofunción como de hiperfunción tiroidea. Si predominan los estimuladores la resultante es un hipertiroidismo, si prevalecen los bloqueadores ocurre un hipotiroidismo y los citotóxicos producen destrucción tisular con hipofunción definitiva. En los dos primeros casos puede haber recuperación espontánea en un tiempo variable.

c) Presentación clínica. La mayoría de estos casos consultan por:

- Bocio
- Enlentecimiento del crecimiento
- Retraso en el proceso de desarrollo sexual
- Retraso en la aparición de la menarca
- Alteraciones del ciclo.
- La presencia de bocio obliga a considerar los siguientes diagnósticos diferenciales, además de investigar el estado de la función tiroidea:
- Tiroiditis linfocitaria crónica (TLC)
- Alteraciones enzimáticas de la síntesis hormonal de expresión tardía.
- Bocio multinodular
- Bocio simple

La primera afección es una de las causas más frecuentes de bocio, en la proximidad de la etapa puberal y puede manifestarse con distintos grados de compromiso de la producción hormonal,

según el momento evolutivo de la enfermedad. Cuando el bocio depende de fallas enzimáticas siempre está acompañado por hipotiroidismo, y en los dos últimos casos la función tiroidea es normal. Los anticuerpos son positivos en la gran mayoría de los pacientes con TLC, mientras que en el resto de las afecciones son negativos. En un escaso porcentaje de pacientes con enfermedad inmunológica se compromete la función tiroidea sin ocasionar bocio. En general no hay reconocimiento de síntomas de hipotiroidismo por parte del paciente y su familia. Sin embargo, es frecuente que en el examen clínico se evidencien signos de la afección (Tabla 4).

Es frecuente que tanto la familia como el pediatra confundan con bocio, al rodete de tejido celular subcutáneo que suelen presentar algunos niños de manera constitucional o acompañando a un aumento exagerado de peso.

Se debe tener presente que las enfermedades tiroideas autoinmunes se presentan con mayor frecuencia que en la población general en las siguientes situaciones clínicas:

Diabetes insulino-dependiente

Síndrome de Down

Síndrome de Turner

Vitiligo

Enfermedad celíaca

Enfermedades autoinmunes que afectan a otros órganos.

El pediatra debe investigar afecciones inmunológicas de la glándula tiroides cuando controla a los pacientes que padecen alguna de las enfermedades referidas.

d) Evolución: semejante a la descrita en el grupo etario anterior.

2.2 - Hipertiroidismo

a) Definición. Es la situación clínica resultante del exceso de hormonas tiroideas libres en la circulación general.

b) Etiología. Es autoinmune y su aparición está facilitada por ciertos factores desencadenantes entre los que se encuentra el stress emocional. Para algunos autores el bocio tóxico difuso (Enfermedad de Graves) y la TLC serían extremos del espectro clínico de una misma enfermedad.

c) Fisiopatogenia. Los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH se unirían al mismo, activándolo y provocando aumento de la captación de yodo, de la síntesis hormonal y de la liberación de hormonas tiroideas.

d) Edad de aparición. Coincide con la ya referida para la TLC, con mayor frecuencia de presentación en la pubertad y años siguientes.

e) Presentación clínica. Es variable y generalmente los signos se van instalando de a poco. En ocasiones el cuadro pasa desapercibido por mucho tiempo antes de que se realice la consulta. Es frecuente que los niños presenten alteraciones en la concentración y en la conducta, que le originan dificultades de aprendizaje y en la relación con sus pares. Con la progresión del cuadro aparece temblor fino que altera la escritura, dificultades para dormir lo que compromete aún más el rendimiento diurno, intolerancia al calor, y alteraciones cardiovasculares (taquicardia, pulso saltón, hipertensión sistólica con aumento de la diferencial y palpitaciones). La piel aparece caliente en tronco y húmeda, especialmente en el dorso de las manos. Como consecuencia del hipermetabolismo estos pacientes ingieren mucha cantidad de alimentos y sin embargo descienden progresivamente de peso. Sin embargo en algunos casos con natural tendencia al sobrepeso, no se produce el adelgazamiento característico. En ocasiones aparece exoftalmos como consecuencia de la acción de determinadas inmunoglobulinas sobre los tejidos orbitales. La mayoría de los pacientes presentan bocio.

f) Diagnóstico. Es simple cuando están presentes todos los síntomas. Pero una vez más su detección temprana implica un desafío para el pediatra, cuando la consulta está motivada por los signos iniciales.

g) Evolución. Los riesgos de esta enfermedad dependen del hipermetabolismo al que el paciente está sometido. Librada a su evolución natural podría progresar hasta una consunción extrema incompatible con la vida. También en esta afección como en el hipotiroidismo debe considerarse la alteración en la calidad de vida a la que se ven sometidos estos niños y jóvenes.

h) Comentarios. Es frecuente que en esta afección, especialmente durante la etapa puberal, las familias lleguen a la consulta preocupadas por las alteraciones de la conducta y en el desempeño escolar. Hasta ese momento la hiperorexia y el adelgazamiento suelen interpretarse como parte de los cambios físicos puberales, y las diferencias en la conducta y en el rendimiento escolar como dependientes del ingreso a la adolescencia.

Se debe sospechar esta enfermedad cuando se

perciban cambios bruscos en la conducta y en el rendimiento escolar en niños que han presentado un comportamiento normal hasta ese momento. Debe investigarse la presencia de hipertiroidismo cuando se detecten signos cardiovasculares tales como: taquicardia, hipertensión arterial, o palpitaciones sin causa aparente.

2.3 - Nódulos tiroideos

a) Definición. Es una lesión focal hiperplásica de la glándula tiroides con características diferentes a las del parénquima adyacente.

b) Etiología. Muchas enfermedades tiroideas benignas o malignas, de etiología genética, infecciosa o inmunológica pueden presentarse como un nódulo (Tabla 5). El desafío para el pediatra ante esta consulta, es establecer la diferencia entre un proceso benigno y maligno que le permita definir la conducta a seguir.

c) Diagnóstico y evolución. Depende de la etiología. Merece consulta especializada.

d) Comentarios. En algunos casos de cáncer de tiroides, el compromiso del parénquima glandular pasa desapercibido durante mucho tiempo o puede no dar expresión clínica, hasta que se hace evidente el abultamiento provocado por una adenopatía metastásica en la región laterocervical próxima a la glándula. En estas situaciones el diagnóstico tardío agrava el pronóstico de la enfermedad. En general el tratamiento temprano permite una buena evolución, aunque en los últimos años se ha detectado una mayor agresividad de la afección.

Todo nódulo de tiroides o una adenopatía laterocervical próxima a la glándula, sin características inflamatorias francas y sin una causa evidente, debe obligar a la presunción de una enfermedad tiroidea maligna. Es una urgencia pediátrica. El cáncer de tiroides es una enfermedad que diagnosticada tempranamente puede tener una resolución favorable mediante la asociación de tratamiento quirúrgico y la administración de yodo radioactivo.

3 - Métodos de evaluación de la glándula tiroides

Estudio funcional: Determinaciones hormonales: T3, T4, T4 libre y TSH. De elección T4 y TSH. Centellografía con yodo ¹³¹I. Utilizada sólo por el especialista para la evaluación de situaciones puntuales. Prueba de TRH. Debe ser indicada e interpretada por el especialista.

Clasificación	
Benignos	
Adenomas	
Anomalías del desarrollo tiroideo	
Absceso tiroideo	
Bocio multinodular	
Tiroiditis	
Quistes	
Malignos	
Carcinoma	
Infiltración de procesos extratiroideos	

Tabla 5. Clasificación etiológica de los nódulos de la glándula tiroides.



Figura 1. Esquema con las distintas localizaciones probables del tejido tiroideo ectópico.

Localización de la glándula y estudio de su estructura: Centellografía con Tc Ecografía

Evaluación inmunológica: Determinación de anticuerpos antitiroglobulina y antifracción microsomal, antireceptor de TSH.

Evaluación histológica: Punción biopsia

4 - Tratamientos de las enfermedades tiroideas

Como en todas las enfermedades endocrológicas, el tratamiento de las disfunciones tiroideas tiene como principal objetivo corregir las consecuencias del funcionamiento glandular al-

terado, alcanzando el eutiroidismo. En los cuadros con déficit hormonal corresponde diseñar el correspondiente reemplazo y en los de exceso frenar la producción exagerada.

Si bien existen dosis estimativas de los diferentes medicamentos a utilizar, en ambos casos éstas deben ajustarse de acuerdo a la respuesta de los pacientes evaluada en base a la clínica y los resultados de laboratorio. Por lo tanto existe una dosis de Levotiroxina en el hipotiroidismo o de Metimazol en el hipertiroidismo, individualmente estimada para cada paciente, que depende de la magnitud del defecto, de la edad del niño y de la respuesta obtenida. En el caso de los nódulos tiroideos el enfoque terapéutico depende de la etiología.

Conclusiones

En los controles de salud de los niños siempre debe investigarse la presencia de signos de sospecha de disfunción endocrinológica. En esta especialidad tan vinculada a los procesos de crecimiento y desarrollo, donde los signos de casi todas sus patologías son muy discretos en su comienzo, debe agudizarse al máximo la observación ya que es trascendente llegar tempranamente a los diagnósticos para que los tratamientos resulten eficaces y puedan evitar las secuelas de la enfermedad. La mayoría de las enfermedades endocrinológicas no se presentan con signos floridos. Ellos pueden ser descubiertos tempranamente sólo si se los investiga. Únicamente el pediatra puede contribuir al diagnóstico precoz. El especialista recién puede participar después de la presunción por él formulada.

La interpretación de normalidad/anormalidad del proceso de crecimiento y desarrollo del niño, es una herramienta semiológica de gran utilidad para presumir tempranamente una gran mayoría de las enfermedades endocrinológicas durante la infancia.

En la etapa de estudio así como en la de tratamiento una vez confirmada la enfermedad, el pediatra debe integrar el equipo ampliado de atención del niño. El endocrinólogo pediátrico y su equipo de colaboradores (laboratorio especializado, medicina por imágenes, psicopatología, asistencia social, enfermería especializada) se responsabilizarán por el tratamiento del niño en lo referido a su afección glandular y el pedia-

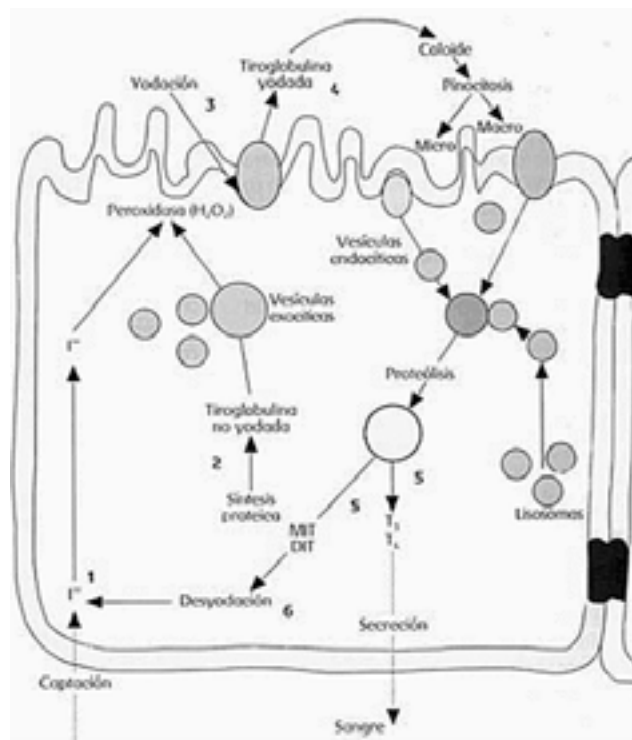


Figura 2. Esquema de la síntesis de hormonas tiroideas

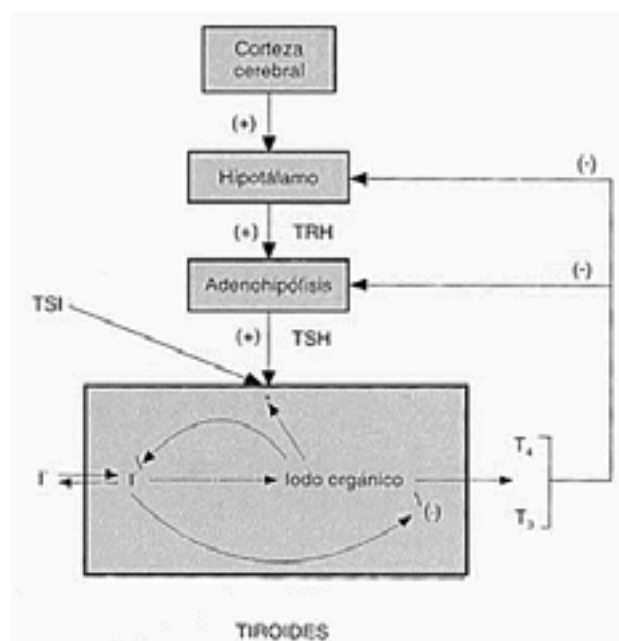


Figura 3. Esquema del eje tirotrófico

tra por su parte, en estrecha comunicación con el grupo especializado, conducirá a la familia y al paciente en su nueva condición de enfermo crónico. Además debe seguir actuando como marco de contención para todas las otras situaciones que habitualmente acontecen en la vida de un niño.

***Dra. Zulma Cristina Santucci**

Médica Pediatra. Endocrinóloga infantil Especialista en Pediatría.

Especialista Consultora en Endocrinología Pediátrica.

Ex Jefa de Sala de Endocrinología y Crecimiento Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.

Integrante de la Comisión Coordinadora del Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas, Ministerio de Salud Provincia de Bs. As (PRODYTEC). Ex Integrante de la Comisión Evaluadora de Tratamientos con Hormona de Crecimiento (CE-THOC), Programa Provincial de Financiación de Tratamientos con Hormona de Crecimiento del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As (PPFTHC).

Integrante de la Comisión Asesora del Programa Nacional de Financiación de Tratamientos con Hormona de Crecimiento, Ministerio de Salud de la Nación.

Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica (SLEP).

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA



DRA. DAIANA PÉREZ*

DR. ALEJANDRO OSTROSKY**

Sumario

La cirugía ortognática, del griego Orthos, “recto”, y Gnathos, “mandíbula”, es una intervención quirúrgica que se encarga de corregir las deformidades dento-cranio-maxilofaciales mediante movimientos óseos maxilares y mandibulares, llevándolos a una posición más estética, funcional y saludable.

Introducción

Este tipo de alteraciones faciales aparecen en la fase de crecimiento de los pacientes, se estabilizan al final de la misma, y pueden causar desequilibrio del sistema neuromuscular, con el consiguiente deterioro de funciones esenciales como la respiración, la masticación y la fonación. Están asociados a la apnea del sueño, trastornos de la ATM, problemas de maloclusión, falta de armonía esquelética, entre otros, además de generar efectos negativos relacionados con la autoestima, la confianza y la salud mental.

Las deformidades dentofaciales son muy frecuentes, entre un 8 y un 12 por ciento de la población mundial presenta algún tipo de alteración, siendo las más frecuentes la Clase 2, Clase 3, asimetría facial y mordida abierta anterior. En cuanto a la demanda de este procedimiento se observa en una relación 3:1 en mujeres y hombres y es más frecuente en jóvenes entre 16 y 28 años.

Se han sugerido varios tratamientos para corregir estas deformidades. La cirugía ortognática combinada con el tratamiento de ortodoncia se considera el gold standard para la corrección de deformidades moderadas a severas. Los pa-

cientes deben comenzar con el tratamiento ortodóntico para reposicionar las piezas dentarias dentro de sus bases óseas, descompensándolos y acentuando su patología. Esto demora de 12 a 24 meses. Una vez finalizada la ortodoncia prequirúrgica, se toman los modelos, se realiza el montaje en articulador y se confecciona la cirugía de modelos en base a la cual, y teniendo en cuenta los estudios radiográficos previamente solicitados, el ortodoncista planificará el caso y lo discutirá con el cirujano que lo llevará a cabo.



Fotografías extraorales preoperatorias de frente y perfil



Fotografías extraorales posoperatorias de frente y perfil

Luego de la cirugía el paciente deberá continuar con la ortodoncia alrededor de 6 meses más para lograr la oclusión deseada.

El objetivo de este tratamiento es lograr una oclusión funcional, simetría facial y dental, estructuras orofaciales saludables y estabilidad entre los arcos dentales. Además de mejorar el bienestar psicosocial y estético de los pacientes, es decir, todos los componentes de la calidad de vida.

Caso Clínico

Paciente femenina de 20 años concurrió al servicio de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno por maloclusión, dificultad para la masticación y mejora estética.

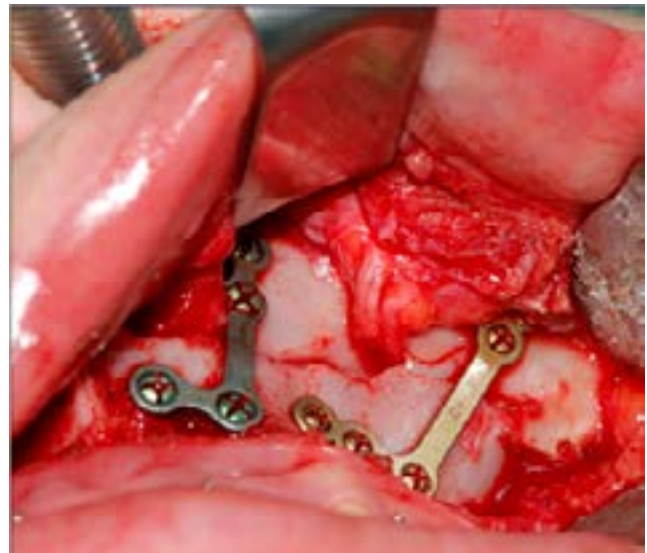
Se derivó al ortodoncista el cual le colocó la ortodoncia prequirúrgica, realizó la planificación del caso con ayuda de los estudios complementarios y se procedió a realizar la cirugía.

Luego de la intubación nasotraqueal y mediante abordajes intraorales, se efectuó la demarcación de las osteotomías sagitales de rama, se realizó la fractura tipo Le Fort I con la disyunción pterigomaxilar y mediante el splint inicial, y teniendo en cuenta las medidas iniciales tomadas, se procedió a fijar el maxilar superior con 2 placas de osteosíntesis de sistema 2.0 en L de cada lado. Completamos las osteotomías inferiores, se coloca el splint final, medimos nuevamente para reubicar la mandibular respetando la planificación y se fija con 3 tornillos bicorticales en forma de L invertida. Se controla la hemostasia y se chequea la oclusión junto con la correcta posición de cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Fijamos el tabique y las alas nasales a la espina nasal anterior y se sutura por planos.

Conclusión

La cirugía ortognática es un procedimiento muy utilizado para la corrección de defectos dento-craneo-maxilofaciales que no pueden ser solucionados con tratamiento ortodóncico. El objetivo es devolver la función, salud y estética del sistema estomatognático, así como la confianza y seguridad del paciente.

Es de suma importancia tener una buena comunicación con el paciente así como su adhesión al tratamiento ya que durante gran parte del proceso se acentuará su patología, cabe



Fotografía intraoperatoria de la fijación de maxilar superior con placas en L



Fotografía intraoral preoperatoria



Fotografía intraoral posoperatoria



Radiografía panorámica posoperatoria donde se puede observar la osteosíntesis colocada

recalcar que los pacientes son adolescentes en su mayoría, pudiendo generar inconformidad e incluso abandono antes de poder completar la fase quirúrgica.

Bibliografía

-

AO CMF Surgery Reference. Website of AO Foundation
Gao JY, Yu XQ. Efficacy of orthodontic and orthognathic treatment for oral and maxillofacial deformities. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Sep;98(39):e17324. doi: 10.1097/MD.00000000000017324.

Gregoret Jorge. Ortodoncia y cirugía ortognática, diagnóstico y planificación. Amoba 2da Edición. 2015

Posnick JC, Kinard BE. Orthognathic Surgery Has a Significant Positive Effect on Perceived Personality Traits and Perceived Emotional Facial Expressions in Subjects With Primary Mandibular Deficiency. *J Craniofac Surg*. 2019 Oct 10..

Posnick Jeffrey C.. Orthognathic surgery, principles and practice. Edición 2014

***Dra. Daiana Pérez**

Odontóloga Cirujana Bucomaxilofacial. Residente Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno

****Dr. Alejandro Ostrosky**

Jefe de servicio Odontología Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno

FRACTURAS DEL MACIZO CRÁNEO FACIAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS



DRA. ELENA MAIDOL*

DR. ALEJANDRO OSTROSKY**

Sumario

Se ha demostrado en varios estudios de trauma maxilofacial que las lesiones de la dicha región son menos comunes en niños que en adultos. [1] Además, los estudios han demostrado que las lesiones tienden a ser, en general, menos graves en los pequeños que en los niños mayores gracias a su predominio de aporte vascular endostial [2,4]

Según diferentes revisiones bibliográficas se estima que hay un predominio del trauma facial en el sexo masculino de 2:1 y que cerca del 100% presenta lesiones asociadas de tejidos blandos, el 44% corresponde al labio superior, el 14% abarca la mejilla y el porcentaje restante, otras regiones. Dentro de la cavidad oral el órgano más lesionado es la lengua.

Con lo que respecta a las fracturas, los masculinos se llevan el 84% de la patología traumática. Los sitios más representantes están dados principalmente por la mandíbula, y en segundo lugar por el maxilar.

Introducción

Los niños constituyen el 5% aproximadamente de todas las fracturas mandibulares, y a menudo este tipo de fracturas son sin desplazamiento, mínimo desplazamiento o en tallo verde debido a la mayor elasticidad de la misma y a la presencia de gérmenes dentarios.

Los patrones de fractura dependen del nivel de

desarrollo mandibular. Las fracturas por compresión del cóndilo, son comunes en la primera infancia debido a un cuello condilar corto, grueso, muy esponjoso, y al radio del hueso cortical. El riesgo aumenta a medida que los niños crecen y el cuello se torna más delgado y se alarga. Además, siempre se debe descartar lesiones traumáticas asociadas. Se ha demostrado que en un 76% de los casos, trae fracturas apareadas. [5]

Varios factores contribuyen a la incidencia significativamente mayor de caídas en el grupo etario más joven: Con la disminución de la edad, inseguridad de movimiento y el equilibrio, aumenta las probabilidades de trauma facial, teniendo un rango preferencial entre el primer y tercer año, y un pico a los 18 meses, etapa promedio donde el niño comienza a caminar y a jugar independientemente. [2,3,6].

En la actualidad, una gran controversia en el trauma facial pediátrico es el uso de la osteosíntesis. Está claro que las fracturas que alteren forma y función deben ser tratadas quirúrgicamente, pero el planteo es, cuál es la mejor alternativa.

Se sabe que fue discutido el uso de placas de titano en los pacientes pediátricos por su influencia en el crecimiento óseo, y que, por tal motivo, el avenimiento de los materiales de osteosíntesis reabsorbibles. Se discutirá en el siguiente caso.

Caso clínico

Se presentó al servicio de cirugía y traumatología bucomaxilofacial del Hospital Mariano y Luciano de la Vega una paciente femenina de 14 años que ingresó por traumatismo de macizo craneofacial secundario a accidente bici-auto en la vía pública. La paciente no refería antecedentes de importancia.

Al momento del examen, lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio. Movimientos oculares y faciales conservados, mandibulares limitados. Visión positiva y respiración espontánea. Escoriaciones en región peribucal y cervical. (fig 1.) No se constataba hematoma de tabique, ni parestesia de alguna región de la cara. Pares craneales conservados.

Al examen intraoral, oclusión alterada, mordida abierta derecha, escalón fracturario a nivel de pieza dentaria 33, dificultad a la apertura bucal. (fig 2.)

Al examen imagenológico (tomografía con reconstrucción 3D), se constata fractura de ángulo mandibular derecha y parasínfisis izquierda. (Fig 3.)

Se decidió entonces intervención quirúrgica dentro de las primeras 72 hs. Se llevó a cabo un abordaje intraoral para exposición de ambos trazos fracturarios, correcta reducción a través de ligaduras de Erns por buen estado de salud bucodental y totalidad de piezas dentarias. Se fijó con osteosíntesis de carga compartida (placa de titanio 2.0 y 2.3). (Fig 4)

Paciente salió sin fijación maxilomandibular del quirófano. Cursó cuadro posoperatorio con buena evolución, se dio el egreso hospitalario y se cita a control por consultorio externo al cabo de 7 días. Se constató buena oclusión, aumento progresivo de la apertura bucal, ausencia de cuadros álgicos y no refirió dificultad mastictoria. (Fig. 5).

Discusión

La utilización de placas reabsorbibles en cirugía cráneo facial pediátrica es rutinaria en la actualidad, habiendo desplazado al titanio por sus efectos adversos. El material metálico no es ideal porque pueden provocar alteración del crecimiento de la bóveda craneal y algunos autores recomiendan retirarlos. [7] Por otra parte es muy difícil su utilización en cráneos menores de 6 meses por su debilidad.



Fig 1. Paciente en quirófano



Fig 2. Exámen intraoral prequirúrgico

Considerando lo anteriormente dicho, la fijación rígida permanente en un cráneo en crecimiento puede ocasionar por sí misma la aparición de deformidades residuales. [8] Numerosas publicaciones avalan el uso y buen resultado de las miniplacas reabsorbibles en este tipo de pacientes. [9,10] Además que es bien conocido el fenómeno migratorio que acontece durante el crecimiento. Si se optara por una osteosíntesis metálica en estos casos, deben de ser retiradas sistemáticamente, debido a su posible penetración endocraneal con la consiguiente interacción meníngea. La indicación de osteosíntesis reabsorbible en estos casos resulta electiva.

La utilización de placas reabsorbibles en trauma cráneo facial está menos documentada que en cirugía cráneo facial de deformidades, pero es suficiente para comprobar su utilidad. Eppeley y Prevel [11] publicaron en 1997 su experiencia en fracturas del tercio medio facial con el uso de Lactosorb en 30 pacientes. Con un seguimiento mayor de un año, observó una cicatrización adecuada y sin reacciones adversas, aunque el autor recomienda no usarla en fracturas de fragmentos pequeños y finos. Resultados similares fueron publicados por Enislidis y col [12] en una serie de 27 fracturas maxilomales.

Si nos adentramos en el campo de fracturas mandibulares, hay circunstancias específicas como fracturas patológicas, desplazadas, conminutas, de alto impacto, asociadas, donde se impone una fijación segura, suficientemente estable, habitualmente rígida, que proporcione una rehabilitación funcional lo más precoz posible y minimice la posibilidad de complicaciones; En la actualidad, los implantes reabsorbibles no garantizan estas premisas, por lo que resulta electiva la osteosíntesis con titanio.

Los inconvenientes descritos en la literatura incluyen el posible daño de los gérmenes dentarios, la interrupción del potencial osteogénico del periostio al exponer la mandíbula con la consiguiente alteración del patrón de crecimiento, aparición de cicatrices hipertróficas, fundamentalmente en adolescentes, y la posible interferencia del material de osteosíntesis en el crecimiento mandibular. Hay que destacar que todos estos inconvenientes, salvo el último, son comunes para los sistemas de osteosíntesis reabsorbible, e incluso podría pensarse que algo más acentuados debido a los mayores perfiles de sus placas y tornillos. (Champy-1992)

Conclusión

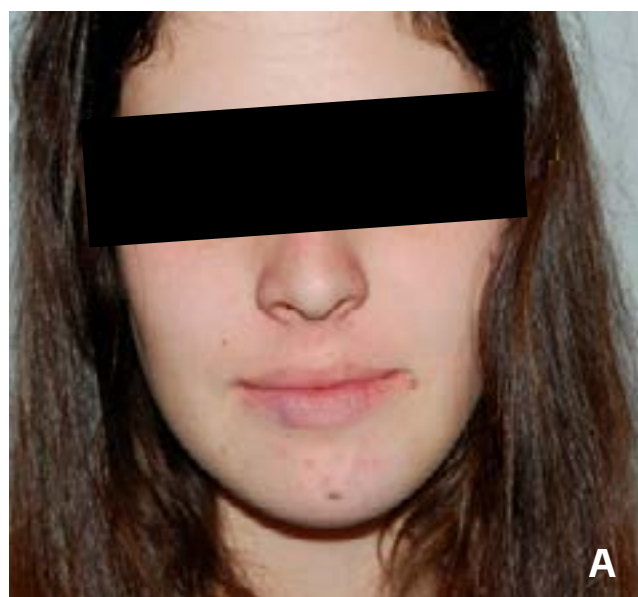
Cuando los abordajes son intraorales las consecuencias de una segunda cirugía pueden considerarse como asumibles, pero en abordajes extraorales (p.e. coronal o submandibular) estas consecuencias no pueden ser desdeñadas. De otra parte, algunos cirujanos postulan que el nuevo abordaje quirúrgico repercute sobre el crecimiento facial de manera similar al tratamiento primario de la fractura, por lo que teniendo en cuenta la reconocida biocompatibilidad de las placas de titanio recomiendan su manteni-



Fig. 3. Tomografía de macizo craneofacial reconstrucción 3D. A. Vista coronal, fractura de parasínfisis izquierda y ángulo derecha. B. Vista sagital, fractura de ángulo de derecha. C. Vista sagital, fractura parasinfisiaria. D. Vista axial, fractura parasinfisiaria que involucra tabla vestibular y lingual.



Fig. 4. Reducción abierta y fijación interna con placas de titanio 2.0 y 2.3.



miento, sobre todo en pacientes mayores de 13 años, salvo que produzcan alguna alteración objetiva. Hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, que las osteosíntesis se manifiestan biomecánicamente activas hasta que la fractura ha consolidado; a partir de este momento se comportan como cuerpos inertes sobre los cuales, y en ausencia de complicaciones, se produce remodelado óseo y osteointegración, pudiendo evidenciarse como el material «acompaña» a la mandíbula en su crecimiento

Siguiendo los postulados de Medicina Basada en la Evidencia, no existe literatura que demuestre relación causal directa entre la presencia de un implante de titanio y una alteración del crecimiento sobre un hueso facial. La experiencia clínica de muchos cirujanos, entre los que nos encontramos, habla en contra de esta posibilidad, por lo que, una vez realizada la pertinente valoración crítica en términos de validez y utilidad, ventajas y desventajas e indicaciones, podemos concluir que esta hipótesis no justifica la no utilización de estos implantes en niños cuando sea necesario, ni la sistemática retirada de los mismos cuando no lo sea.

Referencias bibliográficas

1. Hutchison IL, Magennis P, Shepherd JP, Brown AE. The BAOMS United Kingdom survey of facial injuries. Part 1. Aetiology and the association with alcohol consumption. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1998;36:3-13.
2. Haug RH, Foss J. Maxillofacial injuries in the paediatric patient. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2000;90(2):126-34.
3. Hussain K, Wijetunge DB, Jackson IT. A comprehensive analysis of craniofacial trauma. *J Trauma* 1994;36(1):34-47.
4. Tanaka N, Uchida N, Suzuki K, et al. Maxillofacial injuries in children. *J Craniomaxillofac Surg* 1993;21(7):289-93.
5. Lars Andersson; Karl-Erik Kahnberg; M. Anthony Pogrel. *Tratado de cirugía oral maxilofacial y prótesis para tejidos blandos*. Volumen 2. Cap 42, pág. 897.
6. Zerfowski M, Bremerich A. Facial trauma in children and adolescents. *Clin Oral Invest* 1998;2:120-4.
7. Mühlbauer W, Anderl H, Ramatschi P y cols. Radical treatment of craniofacial anomalies in infancy and the use of miniplates in craniofacial surgery. *Clin Plast Surg* 1987;14:101-11.
8. Posnick JC, Yaremchuk MJ. The effects of nonabsorbable internal fixation devices placed on and within a child's cranial vault: brain function, morbidity, and growth restriction. Editorial. *Plast Reconstr Surg* 1995;96:966-8.
9. Goldstein JA, Qureshy FA, Cohen AR. Early experience with

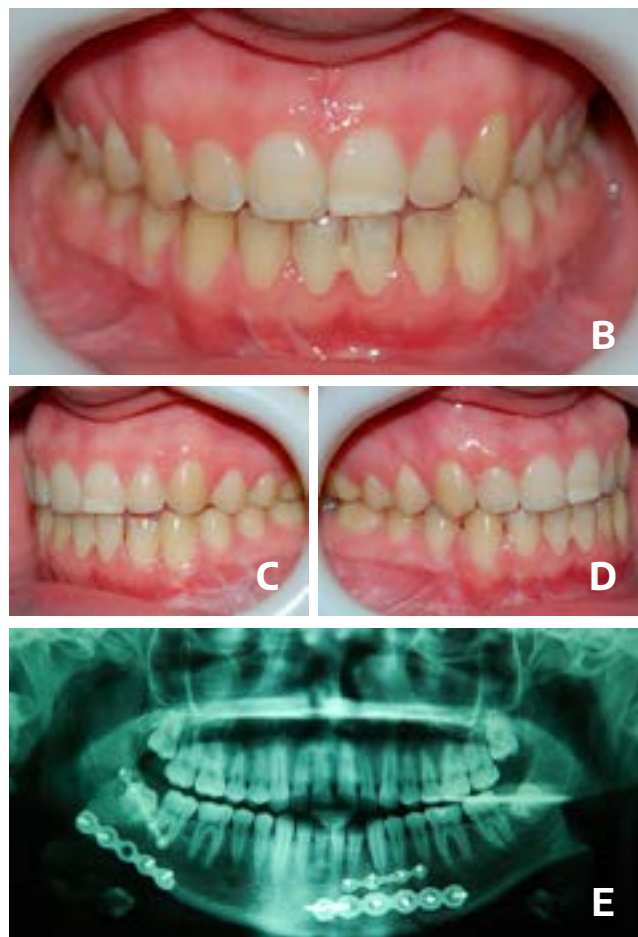


Fig 5. Cuadro posoperatorio. A. Facie posoperatoria. B. Oclusión de frente. D; C. Oclusión lateral. E. Radiografía panorámica posoperatoria.

- biodegradable fixation for congenital pediatric craniofacial surgery. *J Craniofac Surg* 1997;8:110-5.
10. Eppley BL, Prevel CD. Nonmetallic fixation in traumatic midfacial fractures. *J Craniofac Surg* 1997;8:103-9.
11. Enislidis G, Pichorner S, Kainberger F, Ewers R. Fixation of zygomatic fractures with a new biodegradable copolymer osteosynthesis system. Preliminary results. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1998;27:352-5.
12. McCann KJ, Irish JC, Gullane PJ, Holmes H, Brown DH, Rotsein L. Complications associated with rigid fixation of mandibulotomies. *J Otolaryngol* 1994;23:210-15.

*Dra. Elena Maidol

Médica residente de cirugía bucomaxilofacial Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

**Dr. Alejandro Ostrosky

Jefe de servicio Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

ESPASMO DEL SOLLOZO

**Hospital Zonal de Agudos Dr. R. Carrillo de Ciudadela. Servicio de Pediatría.
Residencia de Clínica Pediátrica**



DRA. FABIANA PESTCHANKER

Jefa de Servicio

DRA. FERNANDA NISIMURA

Jefa de Sala

DR. DIEGO PIÑEYRO

Médico de Sala

DRA. MARCELA KOROLUK

Instructora de Residentes

DRA. NATALIA DI POMBO

Jefa de Residentes

DRA. LAURA IDIART

Residente de 4º año

DRA. LUZ MARIEL SUÁREZ LISPERGUER

Residente de 3º año

DRA. PATRICIA FLORES CRUZ

Residente

DR. HEDIM CRISTIAN ARIAS LEÓN

Residente de 2º año

DRA. KAREN RITA SIMÓN ABULARACH

DR. MAURICIO NAVA ORTEGA

Residentes de 1º año

DRA. LUCIANA JIMENA PETRACA*

Revisora

Sumario

El espasmo del sollozo (E.S.) es un evento que ocurre en el 27 % de los niños sanos 1 entre 6 meses y 4-6 años de vida y forma parte de los eventos paroxísticos no epilépticos. Es involuntario, desencadenado por una situación de estrés para el niño con producción de un episodio de hipoxia cerebral aguda 2.

El diagnóstico se basa en una anamnesis del episodio, antecedentes personales y familiares y examen físico del niño

Introducción

El espasmo del sollozo (E.S.) es un evento que ocurre en el 27 % de los niños sanos 1 entre 6 meses y 4-6 años de vida y forma parte de los eventos paroxísticos no epilépticos. Es involuntario, desencadenado por una situación de estrés para el niño con producción de un episodio de hipoxia cerebral aguda 2.

El diagnóstico se basa en una anamnesis del episodio, antecedentes personales y familiares y examen físico del niño. No requiere tratamiento específico, sino más bien tranquilizar y educar a los padres detectando el estímulo externo que lo desencadena, como así también el manejo del evento propiamente dicho una vez presentado.

Definición

El E.S. o del llanto, es un tipo de evento paroxístico no epiléptico que se manifiesta de forma brusca y transitoria, no se deben a actividad neuronal anormal de la corteza cerebral. Se evidencia luego de una espiración prolongada que detiene la respiración y condiciona apnea. El paciente se torna rígido y con cianosis en los labios y en los dedos, o hipotónico y pálido. 2, 3 La pérdida de conciencia, puede o no estar presente.

Incidencia

Los episodios se presentan con una frecuencia de 4-10 % en niños sanos. Inician generalmente entre los 6 y 12 meses de edad, con tendencia a desaparición espontánea a los 4-6 años. La mayor frecuencia del ES se ve entre el primer y segundo año de vida y son excepcionales después de los 4-6 años, mientras que la presentación en el periodo neonatal es rara. Es frecuente que el niño los manifieste por la tarde, cuando está cansado y en especial, cuando se acerca a la hora de ir a dormir.

Causas

El E.S. se originaría en una disfunción cerebral, que no obedece a una descarga neuronal anómala, excluyéndose así de las epilepsias. Es desencadenado por situaciones que provocan llanto, dolor, sorpresa o frustración en el niño, como así también pueden hallarse luego de un traumatismo menor previo al llanto. Si bien sabemos que es un evento involuntario, hay niños que provocar esta dinámica respiratorio y posterior cianosis, con más facilidad y ante estímulos externos de menor cuantía.

Fisiopatología

Se plantean diferentes teorías para su fisiopatología:

- 1.- Tendría cierto grado de relación con disfunciones familiares
- 2.- Uno de cada cuatro niños con E.S. tiene un familiar directo que lo padeció en la infancia.
- 3.- La anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina inferior a 8 g/100 ml estaría relacionada con la génesis del E.S. (Esto está descrito en el 23.5% de niños que lo padecen). Debido a que el hierro es importante para el (metabolismo de catecolaminas y la función de los neurotransmisores).
- 4.- Se ha sugerido también que un retraso en la madurez de la mielinización del tallo cerebral (Medido a través de potenciales evocados) podría influir en el desarrollo del trastorno.

Clasificación

Se describen tres tipos de E.S.

A. Tipo cianótico: Son episodios que se inician en el curso de un llanto por frustración, do-

lor o enojo. Después de uno o varios movimientos respiratorios con espiración prolongada, el llanto se interrumpe, entra en apnea, seguido de cianótico, en algunos casos puede haber pérdida de conciencia. Esto puede asociarse con hipotonía generalizada o hipertonía; incluso presentar mioclonías o sacudidas breves. Esta secuencia puede darse de forma completa o incompleta. En cualquier caso, la recuperación es inmediata y espontánea, sin repercusión en las funciones neurológicas ni afectación del neurodesarrollo.

La duración total es de 1-4 minutos.

Se distinguen 4 grados:

Grado 1. Llanto con inspiración prolongada y apnea breve.

Grado 2. Llanto, inspiración prolongada, apnea y acrocianosis.

Grado 3. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis e hipo- o hipertonía.

Grado 4. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis, hipertonía y sacudidas clónicas generalizadas.

B. Tipo pálido o crisis anóxicas reflejas: Después de un traumatismo leve (especialmente en cráneo) o una situación de temor o sorpresa, se inicia el llanto, se pierde la conciencia, el paciente está pálido e hipotónico generalizado y puede presentar también sacudidas o mioclonías de extremidades. Esto es debido a una respuesta cardioinhibitoria aumentada, secundaria a un incremento del tono vagal. En ocasiones, ambas formas alternan en el mismo paciente. Algunos niños con espasmos pálidos presentarán más adelante síncope infantojuvenil como reacción hipervagotónica refleja ante situaciones de estrés.

C. Mixtos: Pueden coexistir espasmos del sollozo pálido y cianótico en un paciente, aunque es poco frecuente.

Diagnóstico

1. Anamnesis de los episodios (familiares y testigos presenciales, factores desencadenantes, síntomas previos, forma de presentación, síntomas posteriores y conducta adoptada).

2. Antecedentes familiares y personales.

3. Historia clínica completa.

4. Exploración: examen físico y neurológico completo incluyendo fondo de ojo. Valorar sig-

nos neurológicos, estigmas cutáneo y desarrollo psicomotor. En algunos casos valoración neuropsicológica familiar y personal.

5. Laboratorio en caso de sospecha de anemia.

6. Valoración neurológica con electroencefalograma deberá de realizarse en caso de sospecha de epilepsia, cuando no exista fenómeno desencadenante evidente y en menores de 6 meses o mayores de 4-6 años.

7. Valoración cardiológica con electrocardiograma en caso de E.S. pálido y siempre que exista compromiso de la conciencia; se descartarán arritmias o síndrome de QT largo.

Tratamiento

No requiere tratamiento como tampoco una medicación específica. Las medidas terapéuticas están orientadas a tranquilizar y educar a la familia para la prevención, control y manejo del episodio.

En caso de confirmar anemia se sugiere tratamiento con dieta y sulfato ferroso.

Es importante hacer un buen diagnóstico ya que así se evitaría numerosos tratamientos farmacológicos innecesarios.

Conclusión

El E.S. es un evento paroxístico no epiléptico, autolimitado, de desaparición espontánea. De etología no concluyente, frecuente en las consultas ambulatorias de la población pediátrica y en algunos casos en la guardia por la gran angustia que representa en los padres. Es de buena práctica clínica realizar diagnósticos diferenciales con otras entidades, inicialmente a través de la anamnesis y un acabado examen físico, en el caso en el que persistan dudas diagnósticas se solicitaran exámenes complementarios y finalmente derivación a especialistas pediátricos si el caso lo requiriera.

El E.S. constituye una experiencia aterradora para los padres, porque el niño se queda inerte y sin respuesta durante la crisis debido a la anoxia cerebral, Como pediatras no debemos subestimar los episodios por lo que es importante brindar la información necesaria sobre este cuadro, contener, calmar a los padres y educarlos de cuando requiere acudir a un centro de salud especializado.

Manejo del espasmo del sollozo

1. Mantenga la calma y háblale tranquilo.
2. Retire los objetos que el niño tenga en la boca y alrededor.
3. Colóquelo de costado.
4. Afloje la ropa al niño.
5. No intente detener el espasmo.
6. Mantenga un ambiente bien ventilado.
7. Al término del espasmo déjelo dormir una pequeña siesta.
8. En caso de que sea provocado por dolor bríndele consuelo y alivio.

¿Cuándo se requiere de reevaluación médica?

1. Cuando los episodios se producen sin un factor desencadenante o durante el sueño.
2. En caso de movimientos de tipo convulsivo.
3. En caso de inicio antes de los 6 meses de edad o después de los 4-6 años.
4. Cuando exista duda diagnóstica.

¿Qué se debe evitar?

1. Maniobras de reanimación.
2. Golpear o bañar al niño con agua fría.
3. No introduzca objetos en su boca ya que puede lesionarla o provocar sofocación.
4. Es muy importante no confundirlo con otras enfermedades convulsivas, evitar en lo posible la administración de medicamentos antiepilépticos.

Bibliografía

-

Alonso Salas M^a Teresa, Palomino García Alfredo. *Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP. Trastornos paroxísticos no epilépticos*. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Martínez Granero MA, Mazagatos Angulo D. *Trastornos paroxísticos no epilépticos*. En: AEPap (ed.). *Curso de Actualización Pediatría 2016*. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 99-111.

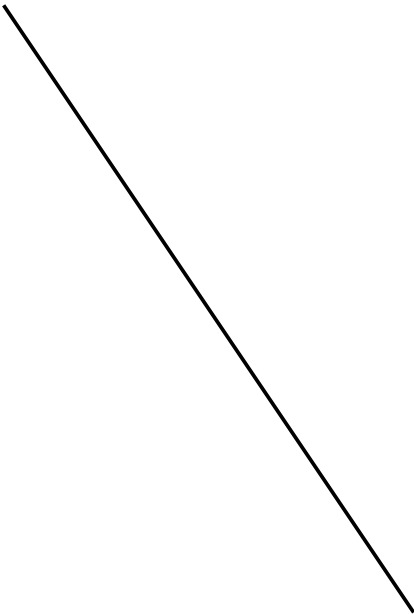
Ortiz Movilla R., M. Muro Brussí, A. Vila Calvo, M. Prados Álvarez y L. Cabanillas Vilaplana. *Hospital Universitario de Getafe. Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría*. Getafe. Madrid. España. *An Pediatr (Barc)*. 2008;69(1):89-102

Ruiz-García Matilde. *Espasmo del sollozo*. *Acta Pediatr Mex* 2014;35:166-169.

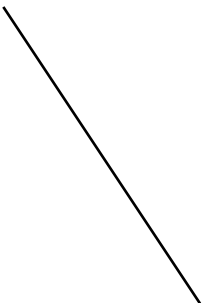
Waisburg HA. *Episodios Paroxísticos no Epilépticos*. Congreso Argentino Ambulatorio, SAP. Noviembre 2018. Salta, Argentina

*Dra. Petraca Luciana Jimena

Servicio de Neurología Infantil, Hospital Italiano de Buenos Aires.



NÚCLEO SITUACIONES CLÍNICAS



Categoría **A**

RECIÉN NACIDO CON ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL

Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda



Dr. Néstor Ñique

Jefe de Servicio

Dra. Leticia Valenciano

Jefa de servicio e instructora de RCP Neonatal

Dra. Verónica Maldonado

Instructora de Residentes

Dra. Estefanía Otero

Jefa de Residentes

Dr. Alejandro Oleiro

Colaborador

Dra. Carolina Pérez

Dra. Silvana Iriarte

Dra. Ayelén Crespo

Residentes

Dr. Ángel Gabriel Mascó *

Revisor

Sumario

El “SALAM” es una enfermedad respiratoria compleja que compromete a los Recién nacidos de Término y cercanos al término a su nacimiento. El mismo combina obstrucción de la vía aérea, atelectasia e inflamación pulmonar con alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar.

Por todas estas razones el manejo integral del SALAM y especialmente el manejo ventilatorio ha sido y sigue siendo un gran desafío para los neonatólogos.

Con un optimizado uso de las modalidades ventilatorias y el uso de las terapias complementarias, los niños con SALAM pueden ser manejados adecuadamente disminuyendo la mortalidad y morbilidad.

Caso clínico

Agustina de 27 años se presenta en la guardia de obstetricia por dolor suprapúbico intermitente de aproximadamente 2 horas de evo-

lución. Presenta un embarazo de 41 semanas según el último control, no adjuntando estudios previos al momento de la consulta.

Se toman muestras de sangre y se realiza monitoreo fetal, en el cual se constata taquicardia fetal. Se decide realizar cesárea de urgencia.

A los 20 minutos nace Olivia, con 41 semanas y peso 4320 gramos, el líquido amniótico es meconial espeso. Presenta circular simple de cordón, coloración verdosa de cabello, uñas, piel y cordón umbilical. Se encuentra hipotónica, cianótica y bradicárdica. Se traslada a sala de recepción, en donde se inicia rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, intubándose con tubo endotraqueal número 3.5 cm y realizándose aspiración de secreciones espesas a través del mismo. Requiere FiO₂ de 100% para lograr una saturación adecuada.

Se toma muestra de sangre de cordón umbilical para realizar estado ácido base que se informa a los pocos minutos: PH 6.98, Co₂ 73, Po₂ 32, exceso de base -16, HCO₃ 8, saturación de

O₂ 75%.

Presenta puntuación de Apgar 1 al minuto, 3 a los 5 minutos, recuperando a 7 a los 10 minutos.

En Neonatología se coloca en incubadora apagada iniciando hipotermia pasiva, se conecta a ventilación mecánica en modo SIMV con presiones inspiratorias y FiO₂ máximos. Se decide canalización de vasos umbilicales y coloca sedación, antibióticos, y se administra surfactante. El monitor multiparamétrico registra una tensión arterial de 34, por lo cual se decide iniciar soporte hemodinámico con dopamina.

En la radiografía toracoabdominal se observan densidades lineales bilaterales y radioopacidad bilateral en ambas playas pulmonares.

Según el cálculo de índice de oxigenación presenta criterio para ingreso en ventilación de alta frecuencia y además, de hipotermia terapéutica, por lo cual se solicita derivación a centro de atención de mayor complejidad, lográndose la misma dentro de las 6 horas de vida. Se informa al padre de la paciente su diagnóstico y pronóstico.

El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial tiene un cuadro clínico que se caracteriza por dificultad respiratoria en un recién nacido a causa de inhalación de líquido amniótico meconial intrauterino o intraparto, con antecedente de presencia de LAM y/o hallazgos de meconio bajo las cuerdas vocales. Es más frecuente en RN de término o postérmino y es excepcional en el pretérmino. Se consideran factores predisponentes todos los responsables de hipoxia perinatal crónica y desencadenantes todos los causantes de hipoxia aguda intraparto, siendo ésta la que desencadena el mecanismo por el que se produce la expulsión del meconio intrauterino.

La fisiopatología puede resumirse como:

- 1) Obstrucción de las vías aéreas de forma total o parcial, más frecuente, que lleva a distensión del parénquima pulmonar con efectos de válvula.
- 2) Inflamación de vías aéreas y pulmones por liberación de factores inflamatorios y por efectos propios del meconio.
- 3) Neumonitis química
- 4) Inactivación del surfactante.

El cuadro clínico es muy variable según el grado de aspiración meconial, siendo lo más frecuen-

te que se presente como dificultad respiratoria transitoria que puede o no requerir oxigenoterapia y que generalmente tiene buena evolución en 24-72 horas. Los cuadros más severos, se presentan con insuficiencia respiratoria progresiva.

La hipoxia progresiva genera que el tórax presente hiperexpansión, principalmente en el diámetro antero-posterior, rales crepitantes y subcrepitantes, coloración pálida grisácea y acidosis metabólica. Pueden asociarse con hipertensión pulmonar persistente. Entre 10 – 40% de estos pacientes presentan neumotórax y/o neumomediastino, generando desmejoramiento súbito.

El patrón radiográfico depende del grado de afectación pulmonar, generalmente presentan infiltrados gruesos multifocales con áreas de mayor aireación, por atrapamiento aéreo, y aplanamiento diafragmático. Se pueden asociar:

- ✓ Atelectasias, cuando el meconio produce oclusión completa de la vía aérea periférica, junto con áreas hiperinsufladas de forma compensatoria, patrón Parcheado o “en panal de abejas”.
- ✓ Neumotórax, cuando hay oclusión parcial, por la presencia de meconio, de la vía aérea periférica.
- ✓ Neumonitis química, responsable del edema pulmonar.
- ✓ En algunos casos existe disociación entre el cuadro clínico y el patrón radiográfico, característico de la enfermedad.

Es importante hacer diagnóstico diferencial con déficit de surfactante, sepsis con edema pulmonar, neumonía, cardiopatía congénita, asfixia perinatal con miocardiopatía e hipertensión pulmonar persistente aislada.

COMPLICACIONES

Fuga de aire: El 10 – 40% de los pacientes con aspiración meconial desarrollan neumotórax o neumomediastino.

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido: Se asocia en aproximadamente en una tercera parte de los casos.

Neumonitis infecciosa, dado que el meconio por su alto contenido de polisacáridos constituye un buen caldo de cultivo para, por ej., *Escherichia coli*

TRATAMIENTO

- ✓ Cuidados del recién nacido
- ✓ Debe procurarse minimizar la estimulación táctil.
- ✓ Hay que realizar la mayor restricción de líquidos posible para prevenir el edema cerebral y pulmonar.
- ✓ Podrá precisar tratamiento específico para la hipotensión con el uso de fármacos cardiotónicos y/o vasopresores
- ✓ Mantener un hematocrito superior al 40%

Oxigenoterapia

El objetivo es mantener una oxigenación sistémica aceptable que consiste en sostener la Saturación periférica entre el 92% y el 96% o la PaO₂ entre 60 y 80 mmHg. Es crucial proporcionar oxígeno suficiente, ya que los episodios intermitentes de hipoxia pueden dar lugar a una vasoconstricción pulmonar constante y contribuir al desarrollo de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.

Ventilación mecánica

La ventilación mecánica está indicada en caso de retención excesiva de dióxido de carbono (PaCO₂ mayor a 60 mmHg) o hipoxemia persistente (PaO₂ menor a 50 mmHg); con frecuencia son necesarias presiones inspiratorias más elevadas unos 30 – 35 cm H₂O y un volumen corriente mayor que en los niños con síndrome de dificultad respiratoria.

Se debe permitir un tiempo inspiratorio adecuado para prevenir el atrapamiento aéreo, de 0,4 a 0,5 seg. asociado a una frecuencia de 20-25 resp/min, no frecuencias respiratorias altas que favorezcan el atrapamiento aéreo.

La ventilación de alta frecuencia puede conseguir buenos resultados en niños graves que no mejoran con la ventilación convencional y en los que desarrollen fuga de aire.

Óxido Nítrico Inhalado (ONi): Produce una vasodilatación pulmonar potente y sostenida local, sin disminuir el tono vascular sistémico.

Las indicaciones son un índice de oxigenación mayor a 25 con evidencia ecocardiográfica de cortocircuito extrapulmonar de derecha a izquierda. En pacientes gravemente enfermos

con SAM e hipertensión pulmonar, el óxido nítrico inhalado reduce la necesidad de ECMO.

Oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO): Es el tratamiento de último recurso y se utiliza cuando se estima que la mortalidad es muy alta.

Fármacos

Antibióticos: Puede ser difícil distinguir entre una neumonía bacteriana y la aspiración de meconio por lo que suele estar indicado el uso de antibióticos de amplio espectro (por ej. ampicilina y gentamicina) en aquellos que muestran infiltrados en la radiografía de tórax; se debe realizar hemocultivos para identificar bacteriemia, si existe, y determinar la duración del ciclo de antibióticos.

Surfactante: La actividad del surfactante endógeno puede estar inhibida por el meconio y además tiene un efecto citotóxico sobre los neumocitos tipo II y reduce los niveles de proteínas surfactantes A y B.

Varios ensayos han evaluado el lavado pulmonar con surfactante y los neonatos que reciben este tratamiento tuvieron resultados más favorables, tales como una mejora más rápida y sostenida de la oxigenación.

Corticoesteroides: Contrarrestan la intensa inflamación que se produce pocas horas después de la aspiración, administrado de forma sistémica o por vía inhalatoria.

Ensayos clínicos han demostrado una disminución en la necesidad de oxígeno y mejoría radiológica y no existe hasta el momento suficiente evidencia para recomendarlos como tratamiento de rutina en el SAM.

Se encuentra en estudio los inhibidores de fosfodiesterasa selectivos (milrinona) y no selectivos (aminofilina), comprobando sus propiedades antiinflamatorias, pero vigilando cuidadosamente los efectos hemodinámicos.

Sedantes: Los niños que requieren ventilación mecánica pueden precisar sedación y relajación muscular.

Antioxidantes: El uso de antioxidantes y en particular de N-acetilcisteína, para mitigar la lesión pulmonar inducida por especies reactivas de oxígeno.

Experto

El "SALAM (como también lo denominamos) es una enfermedad respiratoria compleja que compromete a los Recién nacidos de Término y cercanos al término a su nacimiento. La misma combina obstrucción de la vía aérea, atelectasia e inflamación pulmonar con alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar.

Por todas estas razones el manejo integral del SALAM y especialmente el manejo ventilatorio ha sido y sigue siendo un gran desafío para los neonatólogos (mencionaremos en la presente terapias respiratorias complementarias).

La disfunción pulmonar presente en el SALAM se asienta sobre el interjuego de severos disturbios fisiopatológicos entre los cuales priman la obstrucción de la vía aérea, zonas de atelectasias e hipertensión pulmonar produciendo una Neumonitis Aspirativa basada en la inhibición de la función del Surfactante y toxicidad del epitelio pulmonar, lo que causa alveolitis hemorrágica (con altas concentraciones de Proteínas y Albumina en el espacio alveolar) generando disrupción de la barrera alveolo-capilar y consecuente edema exudativo.

Por lo tanto la yuxtaposición de áreas atelectasias con unidades pulmonares normalmente aireadas y/o hiperinsufladas da por resultado una imagen radiológica típica e irregularmente opacificada.

Los más importantes efectos fisiológicos dados por la injuria meconial en la vía aérea son: la hipoxemia y la disminución de la compliance pulmonar (existe una disminución de la ventilación perfusión a través de los shunts intrapulmonares), ocasionando atelectasias, sobredistensión, hipertensión pulmonar o combinaciones de los mismos.

La hipertensión pulmonar persistente es multifactorial contribuyendo a la misma: baja PO₂ y PH, asfixia intrauterina y la posibilidad de sustancias vasoactivas en el meconio.

Refiriéndonos a la Terapia múltiple y compleja con conlleva al manejo de estos pacientes, probablemente la oxigenoterapia ocupe un lugar relevante, siendo la misma el pilar del tratamiento del SALAM. Los ajustes de la Fio₂ serán dinámicos (momento a momento) de acuerdo a la monitorización de Sat O₂ preductal (oximetría de pulso) o PO₂ (muestra de sangre arterial

radial derecha), dada la alta incidencia de shunt ductal de derecha a izquierda.

Los objetivos a perseguir es mantener (por lo previamente comentado) una Sat O₂ entre 94%-98% y PO₂ 60-100 mmHg (en RNT o cercanos al término).

De todos los niños que requieren soporte ventilatorio, aproximadamente 10-20% serán tratados con NCPAP solamente, y un 25% de los niños que requerirán intubación (antes o después de la misma) recibirán NCPAP.

La presión de CPAP se ajustara entre 5-8 cmH₂O (no mayor por riesgo de generar síndrome de escape de aire).

Aproximadamente 1/3 de los niños con SALAM requerirán TET/ARM, los criterios incluirán:

* FIO₂ > o igual al 80%

* PH persistente < o igual a 7.25

*HPP

* compromiso hemodinámico (hipotensión arterial, mala perfusión)

Una vez el paciente intubado requerirá el manejo del dolor/sedación con infusión de un opioide (Morfina-Fentanilo) asociado en algunas circunstancias a una BZD.

El modo de ventilación y el Setting a programar es variable y depende de las circunstancias del paciente. Sin embargo pareciera en la actualidad que SIMV sería la opción mejor sobre IMV, ya que la primera está asociada a más corta duración en ARM.

Con respecto a PEEP: un cuadro en el que predomine la Atelectasia podría llevar a alcanzar PEEP 8-10 cmH₂O lo que mejoraría la oxigenación, en cambio cuadros en los que predomine la hiperinsuflación regional o global deberían utilizarse PEEP 3-4 cmH₂O que podrían igualmente y bajo estas circunstancias ser efectivos sin colocar al paciente en riesgo de aparición de un Neumotórax.

Con respecto a PIM: dado la reducida compliance los valores requeridos para generar suficiente volumen TIDAL es a menudo alta (PIM > o igual 30 cmH₂O) lo que expondría al Pulmón a las consecuencias del Barotrauma, por lo cual debería pensarse en la necesidad de HFOV ante esta circunstancia. Un aceptable rango de una muestra de sangre arterial sería PCo₂ 40-60 mmHg y un PH 7.30-7.40.

Ante el fracaso de ARM convencional, debería iniciarse entonces HFOV. Las estadísticas de-

muestran que el 20-30% de niños que requirieron TET/ARM necesitaran HFOV para proteger al pulmón de muy altas PIM con la consecuente injuria pulmonar.

La MAP inicial: será 2 cm H₂O mayor que la alcanzada en ARM convencional llegando a valores de 25 cm H₂O aproximadamente.

Los HZ: no deberían ser mayores a 10 HZ (porque podría aumentar el atrapamiento aéreo), preferentemente serían de 6 a 8 HZ.

Los índices que forman parte de los criterios para iniciar HFOV son MAP > 10_12, OI > o igual a 20.

Terapias respiratorias coadyuvantes:

- ✓ Surfactante pulmonar: el SALAM incluye la inhibición del Surfactante del paciente ya sea a través del meconio o el edema por el exudado plasmático proteico. Por lo cual el surfactante exógeno esta propuesto dentro de las terapias a considerar. Se ha identificado alrededor del 40% de pacientes “no respondedores”. Debería ser usado en pacientes con enfermedad severa y tratados tempranamente. Se ha observado una reducción en necesidad de ECMO.
- ✓ Terapia de lavado: el lavado con Surfactante como una posibilidad de tratamiento que ofrecía en teoría la eventualidad de interrumpir la patogénesis de la enfermedad, al remover el meconio. De los espacios aéreos. Se postulaba que podía mejorar la oxigenación y acortar la duración de ARM, sin embargo los trabajos no demostraron tales hipótesis pero si se encontró un alto porcentaje de sobrevivientes que no requirieron ECMO no hubo posteriores trabajos que demostraron este hallazgo).
- ✓ Terapias con corticoides: fue investigado por más de tres décadas; uno de los trabajos sugirió que la terapia con Dexametasona podría disminuir la respuesta inflamatoria en el SALAM pero ante la falta de otros trabajos que lo confirmen y teniendo en cuenta los efectos adversos en el neonato, la misma no está recomendada como una posible terapéutica.
- ✓ Óxido Nítrico inhalado: muchos trabajos controlados-randomizados han demostrado la efectividad del INO en RNT con

hipertensión pulmonar, reduciendo la necesidad de ECMO. La combinación de INO + HFOV mejora sustancialmente el resultado de cada una de ellas por separado disminuyendo el número de no respondedores a los mismos, cerca del 20-30% de los niños con SALAM ventilados reciben INO y alrededor del 40-60 % presentan una buena respuesta. Cuando la HPP se ha incorporado al cuadro de base y ha sido corroborado con Ecocardiografía, el INO debería sumarse con PO₂ que permanecen menores a 80-100 mmHg recibiendo FIO₂ 100% y la misma se iniciaría con dosis de 10-20 ppm.

- ✓ Ventilación líquida: la ventilación líquida con perfluorocarbono ha sido investigada en modelos animales con SALAM. Esta técnica ha mostrado ciertas ventajas sobre la ventilación convencional expresados por mejoría en la oxigenación y compliance pulmonar, pareciendo ser más protectora sobre el daño pulmonar resultante de la presencia de meconio en la vía aérea. De todas formas esta línea de estudios fue discutida y en la actualidad no hay trabajos que avalen su uso.
- ✓ Duración de ARM y oxigenoterapia: la media de los niños que requieren ARM es de 3 días y en aquellos más severos que necesitaran HFOV + INO es de 5 días aproximadamente. La estadía hospitalaria media de estos niños suele estar entre 7-10 días aproximadamente; sin la mediación de otras complicaciones potenciales.

Mortalidad

La mejoría sustancial en los cuidados de las UTIN y el soporte respiratorio han contribuido a una disminución significativa de la mortalidad relacionada al SALAM con poblaciones estudiadas que sugieren entre 1-2 por 100.000 nacimientos vivos.

Morbilidades a corto tiempo: Neumotórax alrededor del 10%, atelectasias y HPP, Neumomediastino, Enfisema intersticial pulmonar, Sepsis, entre otras.

Conclusión

Con un optimizado uso de las modalidades ventilatorias y el uso de las terapias comple-

mentarias, los niños con SALAM pueden ser manejados adecuadamente disminuyendo la mortalidad y morbilidad.

Bibliografía

-

Ahumada, L.; Videla Balguer, M.L.; Balbiano, S.; Bellani, P.; Brenner, P.; Ferreira, M.; Meritano, J.; Rognone, A. *Atención y cuidado del recién nacido prematuro cuidados respiratorios pautas y lineamientos prácticos*. Ministerio de Salud de la Nación. 2019
Ceriani Cernadas, J.M.; Mariani, G.; Lupo, E.A.; Jenik, A. *Neonatología Práctica*. 5ta edición, Editorial Panamericana. 2018
Coto Cotallo GD; López Sastre J.; Fernández Colomer, B.; Álvarez Caro, F.; Ibáñez Fernández, A. *Recién nacido a término con dificultad respiratoria: enfoque diagnóstico y terapéutico*. *Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la Asociación Española de Pediatría: Neonatología*. 2008

***Dr. Ángel Gabriel Mascó**

Neonatólogo, Pediatra. Seguimiento de Alto Riesgo neonatal.

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA

Hospital Zonal General de Agudos Isidoro G. Iriarte de Quilmes



Dra. Julieta Cortesini Leavi

Dra. Mariela Iori

Dra. Pamela Ecos Fernández

Dra. Luciana Ourracariet

Dra. Valeria Blois

Dra. Marisa Segovia

Dr. Alejandro Cruz Carrozzo

Dra. Laura Cuellar

Dr. Niko Arredondo Rincón

Dr. Juan Esteban Amigo

Dra. Florencia Chica Vergara

Dra. Fabiola Genilla Rojas

Residentes

Dra. M. Carozzo

Instructora de Residentes

Sumario

La EMH o Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda del Recién Nacido (SDRARN) es un trastorno pulmonar frecuente que se presenta casi de manera exclusiva en el RNPT. Constituye una importante causa de morbilidad y mortalidad en especial en prematuros muy pequeños.

Aproximadamente el 10% de los niños de 36 semanas de gestación o menos padece la enfermedad.

Situación clínica

Recién nacido de sexo masculino, pretérmino de 28 semanas, BPEG 1.200 gr, nacido por ce-

sárea por inicio de trabajo de parto, sin maduración pulmonar.

Inicia en sala de recepción con quejido continuo intenso, mala mecánica ventilatoria, con aleteo nasal y tiraje universal. Se estabiliza al RN con PEEP de 5/6 y FiO₂ 30% con neopuff. Se traslada a UTIN, se coloca en ATN, se realiza IOT y se conecta a ARM modalidad SIMV, setting 17/5/0.35/30/30. Se solicita Rx de tórax y se interpreta el cuadro como síndrome de dificultad respiratoria. Se recibe imagen radiológica y se hace diagnóstico de Enfermedad de membrana hialina (EMH). Se administra dosis de surfactante a 100 mg/kg/dosis, se canalizan vasos umbili-

cales y se toman muestras de laboratorios.

La frecuencia de EMH aumenta en las siguientes situaciones:

- Nacidos por cesárea antes de las 38 semanas en especial si no fue precedida por trabajo de parto.
- Hijos de madres diabéticas insulino resistentes con mal control de la glucemia durante el embarazo.
- Hipoxia perinatal.
- Varones.
- Prematurez (antes de las 34 semanas), aumenta a medida que disminuye la edad gestacional.

Fisiopatología

La causa es el déficit de surfactante a nivel del epitelio alveolar.

El surfactante es una sustancia lipoproteica que se desarrolla y se libera en los pulmones de los mamíferos a medida que progresa la edad gestacional. Su función primordial es la de reducir la tensión superficial, asegura el mantenimiento de un volumen residual pulmonar adecuado y evita el colapso alveolar (atelectasia), que es la alteración anatomopatológica de la enfermedad.

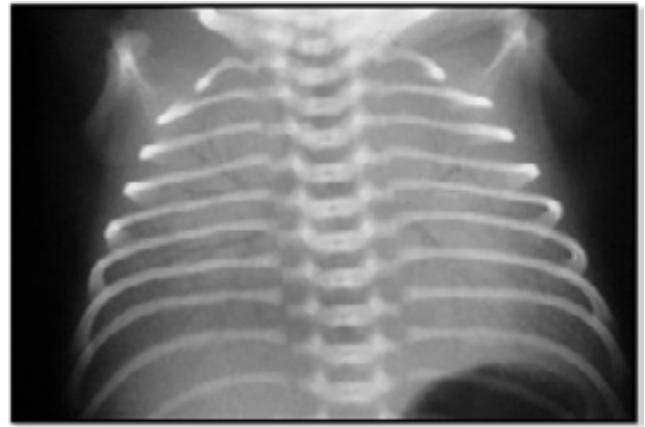
Es sintetizado por los neumonocitos del tipo 2 a partir de la semana 20 de embarazo, completando su síntesis para alrededor de la semana 34-35, donde el pulmón fetal adquiere su madurez.

Diagnóstico

La tríada fundada en: el cuadro clínico (quejido, tiraje y cianosis); datos obtenidos a partir de los métodos auxiliares de diagnóstico (radiografía de tórax y EAB) y antecedentes (prematurez, ausencia de maduración pulmonar) representan la clave para su diagnóstico.

Dentro de los antecedentes maternos es muy importante tener en cuenta que un embarazo prematuro previo condiciona el riesgo de prematurez en el siguiente, ya que este antecedente aumenta las posibilidades en un 75%.

La presencia del trabajo de parto es muy importante para estimular la liberación del surfactante desde los neumonocitos tipo 2 hacia los alveolos. La alteración aguda de la vitalidad fetal puede interferir con su liberación, situación que se da ante la hipoxia- asfixia perinatal.



Existen situaciones excepcionales que consumen surfactante en fetos a término y pos términos, como el síndrome de aspiración de líquido meconial (SALAM) y la neumonorragia.

Clínica

La mayoría de los RN presenta dificultad respiratoria inmediatamente después del nacimiento y hasta 2 hs posteriores a este. Puede llegar a existir un intervalo libre de síntomas que en general se da en RN de entre 35-37 semanas con peso > 2.500gr, o pueden presentar solo taquipnea leve y quejido intermitente (este dato nos orienta más hacia la sospecha de neumonía por *Estreptococo* del Grupo B).

El cuadro clínico clásico presenta:

- ✓ Retracción intercostal
- ✓ Depresión xifoidea
- ✓ Dilatación nasal
- ✓ Taquipnea
- ✓ Cianosis
- ✓ Quejido

Los signos clínicos de dificultad respiratoria se van acentuando en las primeras 24-48 hs, su intensidad habitualmente comienza a decrecer alrededor de las 72 hs y su duración alcanza hasta el 5to o 6to día. Sin embargo las variables de severidad y duración se modifican según la edad gestacional (más severo a menor edad).

Laboratorio

Habitualmente estos niños tienen disminución del PH (<7.25) que será más notable cuanto más importante sea la insuficiencia respiratoria. Esta acidosis es predominantemente respiratoria, ya que se debe a una elevación de la pCO₂ a valores superiores de 45mmHg. Si el curso clínico de la

enfermedad es grave, y existe hipotensión arterial o alguna complicación, suele haber acidosis mixta, es decir, con componente metabólico.

La determinación de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial y la saturación de oxígeno son parámetros fundamentales para establecer el diagnóstico. Estos niños tienen incapacidad para mantener la $PaO_2 > 50\text{mmHg}$ y la $So_2 > 90\%$ respirando oxígeno ambiental.

Es necesario también efectuar otros estudios de laboratorio como: hemograma, glucemia, ionograma, función renal, calcemia. Si hay dudas sobre la posible presencia de infección se solicitarán reactantes de fase aguda.

Radiología

El patrón radiológico típico se caracteriza por:

- ✓ Pulmones poco aireados
- ✓ Moteado fino o un reticulado granulado bilateral difuso denominado “en vidrio esmerilado”
- ✓ Broncograma aéreo
- ✓ Silueta cardíaca mal definida
- ✓ Imagen de timo aumentada

Los hallazgos suelen tener un grado variable según la intensidad del cuadro clínico, diferenciando así 3 grados:

- ✓ GRADO 1: Cuadro clínico leve. Se observa un esmerilado no intenso, broncograma aéreo no muy nítido, silueta cardíaca con límites bien demarcados diferenciándose con claridad del tejido pulmonar. La aireación solo se encuentra levemente disminuida.
- ✓ GRADO 2: Cuadro clínico moderado. Presenta dificultad respiratoria de mayor intensidad y requerimientos de oxígeno más elevados. El moteado granular es bien difuso, los pulmones se observan “opacos” y el broncograma aéreo es más nítido. La silueta cardíaca presenta bordes borrosos que no permiten delinear bien su contorno. La aireación del pulmón está francamente disminuida.
- ✓ GRADO 3: Cuadro clínico grave. Moteado fino intenso generando una opacidad general de todo el pulmón. El broncograma es bien nítido y resulta imposible distinguir la silueta cardíaca, ya que sus límites se confunden con la opacidad del pulmón.

Diagnósticos diferenciales

Si bien hay muchas causas de distrés respiratorio del recién nacido, las principales son 3:

- ✓ Síndrome de dificultad respiratoria transitoria: En general son RN de peso alto o adecuado y con antecedente de cesárea abdominal. La FR no suele ser > 90 resp/m, puede haber retracción intercostal leve, sin otros signos de dificultar respiratoria. La saturación de oxígeno es habitualmente normal y no suele requerir oxígeno.
- ✓ Neumonía: Es especial la producida por *Streptococcus Beta Hemolítico del Grupo B*.
- ✓ Trastornos hemodinámicos graves con falla del miocardio: Pacientes con antecedente de cesárea abdominal; pueden dar imágenes radiológicas muy similares por edema pulmonar por falla de bomba.

Tratamiento

El tratamiento es complejo en especial en RN pequeños, y el éxito depende de múltiples acciones que solo pueden brindarse en unidades adecuadas para pacientes de alto riesgo.

Los cuidados deben comenzar en la sala de partos, con una recepción acertada, en la que principalmente se evite la hipoxia y la hipotermia.

Todo RN que presente dificultad respiratoria debe ser colocado en un ambiente térmico apropiado con control continuo de su So_2 .

Si la So_2 es $< 90\%$ se indicará oxígeno por halo, cánula nasal o TOT, según la gravedad del cuadro.

Si pesa > 1.500 kg y presenta dificultad respiratoria leve a moderada con requerimiento de oxígeno, se comenzará utilizando halo cefálico. Si ésta es más intensa, se debe aplicar presión positiva continua mediante cánula nasal.

En RN con dificultad respiratoria que requiere FIO_2 (fracción de oxígeno inspirada) > 0.4 la indicación es la administración temprana de surfactante.

Cabe destacar que la anemia que es un hallazgo frecuente en la prematurez, en cuadros de EMH severos, condicionando un mayor requerimiento de FIO_2 y parámetros más altos de respirador.

En prematuros pequeños es conveniente

mantener SO_2 entre 88-93%, PaO_2 entre 45-55 mmHg, la PCO_2 entre 45-55 mmHg y el $Ph > 7.20$.

El control de la temperatura es esencial, debe mantenerse un ambiente térmico neutro ya que en esas condiciones el consumo de oxígeno será óptimo.

En los niños con EMH leve y de mayor peso, la administración de oxígeno mediante halo y los cuidados descriptos anteriormente, permitirán una evolución favorable de la enfermedad en 72 a 96 hs. Cuando la oxigenación no puede mantenerse dentro de niveles normales con la administración simple de oxígeno, se debe recurrir a otros métodos.

Presión positiva continúa en la vía aérea (CPAP): se basa en el aumento del volumen residual pulmonar, que se encuentra muy disminuido en la EMH severa. Disminuye de manera significativa el esfuerzo respiratorio y la oxigenación suele mejorar notablemente. Se puede colocar mediante cánula nasal, sonda nasal o faríngea y tubo endotraqueal. Se desaconseja CPAP por tubo Endotraqueal en especial en prematuros <1.500 kg.

En RN con mayor peso, el CPAP permite resolución progresiva de la enfermedad evitando la ARM.

El CPAP es un buen método para elevar la PO_2 , pero no es útil para las alteraciones de la ventilación (hipercapnia).

La presión que se va a aplicar debe ser progresiva, lo habitual es comenzar con presiones entre 4 y 5 cm y observar la respuesta clínica; si no presenta mejoría la presión se incrementa 1 a 2 cm por vez, hasta un máximo de 7 a 8 cm. El exceso de presión puede empeorar el cuadro ya que disminuye el retorno venoso al corazón provocando retención de CO_2 (por excesiva distensión pulmonar).

Para retirar CPAP conviene reducir de manera gradual la concentración de oxígeno y luego ir disminuyendo la presión, cuando ésta es de 2, ya se puede prescindir del CPAP y el RN suele quedar con halo con una concentración de oxígeno ligeramente superior.

Asistencia respiratoria mecánica (ARM): El aumento notable del uso de la ARM en nuestro medio no ha estado acompañado, en todos los casos, por el éxito de los resultados.

Surfactante exógeno: Se diseñaron dos tipos de surfactantes: el natural y sintético. En nuestro medio se emplea preferentemente el surfactante natural de origen bovino. La administración intratraqueal de surfactante, en los estadios iniciales de EMH, produce:

- Mejoría en la oxigenación y el intercambio de gases
- Reducción de las presiones del respirador y la concentración inspirada del oxígeno
- Menor frecuencia de neumotórax y enfisema intersticial
- Tiempo de asistencia ventilatoria más breve
- Disminución de la mortalidad

En su indicación hay dos modalidades:

-Profilaxis: se administra de forma sistemática durante los primeros 30 minutos. Se utiliza en prematuros extremos (<28 semanas) en especial varones cuyas madres no han recibido corticoides.

-Rescate: se administra en los RN que tienen dificultad respiratoria y requieren de $FIO_2 = 0.4$. La administración debe ser temprana, idealmente en las primeras 2 horas de vida, ya que con ello su eficacia aumenta. Las dosis individuales son de 90-100 mg/kg y se pueden aplicar hasta 4 dosis. La indicación de nuevas dosis dependerá del requerimiento de oxígeno y de la presencia de factores de riesgo.

Además de lo ya señalado en cuanto a la necesidad del control cuidadoso de la temperatura y de los líquidos que se administren, es necesario tener en cuenta otros aspectos:

- Obtención de varias muestras de sangre para análisis es una causa de anemia, en especial si el volumen en cada muestra es elevado. Evitar estudios innecesarios y extraer el menor volumen de sangre posible.
- Controlar la presión arterial en forma continua, ya que se puede presentar trastornos hemodinámicos.
- Control de la diuresis para adecuar correctamente el aporte de líquidos. Los diuréticos (furosemida) no están indicados de rutina y raramente pueden ser necesarios.
- La indicación de bicarbonato de sodio solo se justifica en aquellos pacientes que mantienen acidosis metabólica ($pH < 7.20$, con exceso de base >10) o que tienen signos

de HTA pulmonar. Se debe infundir con lentitud y antes de ser administrado asegurar una ventilación pulmonar adecuada. Su uso ha disminuido notablemente.

- Existen controversias sobre la aplicación de antibióticos en los recién nacidos con dificultad respiratoria. Puede incrementar el riesgo de resistencia bacteriana y por ende aumentar las posibilidades de infección nosocomial por gérmenes virulentos o por Cándida.

Prevención

Teniendo en cuenta que esta enfermedad está directamente relacionada con la prematuridad, todas las medidas destinadas a disminuir su frecuencia y realizar un manejo adecuado de la amenaza de parto prematuro y del mismo parto, van a incidir notablemente en el pronóstico de estos niños.

La administración prenatal de corticoides es una de las medidas de mayor importancia y debe ser indicado en toda amenaza de parto prematuro comprobada. Estos ejercen varias acciones:

- ✓ Aceleran el desarrollo estructural por acción sobre el tejido conectivo
- ✓ Aumentan la elastina y el colágeno
- ✓ Aceleran la biosíntesis del surfactante
- ✓ Estimulan la producción de las proteínas específicas del surfactante
- ✓ Estimulan la secreción de surfactante
- ✓ Reducen la pérdida o el pasaje de líquido proteico desde el capilar al espacio alveolar
- ✓ Incrementan el número de receptores adrenérgicos
- ✓ Estimulan la concentración de T3 y tiene efectos aditivos sobre la maduración pulmonar con las hormonas tiroideas y la prolactina

Los corticoides están indicados en todas las madres con embarazos menores de 32 semanas que presentan amenaza de parto prematuro y que no tienen una dilatación cervical > de 5 cm ni signos de infección ovular. Su eficacia es máxima si la madre los recibe entre 24 hs y 7 días antes del parto. Por ello es importante que el trabajo de parto se demore un mínimo de 24 hs para que los corticoides logren mayor efecto.

El esquema más utilizado consiste en aplicar 12 mg de betametasona IM cada 24 hs (2 dosis).

Aún con la administración de corticoides el RN puede padecer EMH. Ello ocurre alrededor del 20 al 30% de los casos (RN <32 semanas) por lo que igual se deben tomar todos los recaudos para que el nacimiento se produzca en un lugar que cuente con una unidad de cuidados intensivos neonatales que permita la asistencia adecuada.

Comentario del Especialista

La prematuridad continúa siendo un problema sanitario a nivel mundial. La ausencia de controles de embarazo adecuados, sumado al escaso nivel socioeconómico materno se asocia con mayor frecuencia a la llegada tardía al sistema de salud y a no recibir de manera adecuada maduración pulmonar antes que se produzca el nacimiento. Esto mantiene constante la incidencia de la enfermedad de membrana hialina en la población mencionada.

Se cuenta hoy en día muchos elementos para estabilizar el pulmón de neonato pretérmino que presenta distress inmediato al nacer. La aplicación de PEEP en sala de partos, el uso de blenders, saturómetros y al CPAP nasal, disminuyen notoriamente la necesidad de intubación y ARM que queda relegada a los embarazos extremadamente prematuros.

Técnicas no tan nuevas como el INSURE (intubación, surfactante, extubación a CPAP) y otras más recientes como el LISA (less invasive surfactant administration), permiten la mejoría del cuadro clínico y disminuyen la frecuencia de complicaciones pulmonares crónicas en el bebé que sobrevive al no requerir la asistencia respiratoria mecánica.

Por último han aparecido nuevas fórmulas de surfactante que mantienen la dosis requiriendo menores volúmenes y menores dosis de aplicación, lo que beneficia notablemente a los prematuros menores de 28 semanas de edad gestacional.

Bibliografía

Ahumada, L.; Videla Balguer, M.L.; Balbiano, S.; Bellani, P.; Brenner, P.; Ferreira, M.; Meritano, J.; Rognone, A. Atención y cuidado del recién nacido prematuro cuidados respiratorios pautas y lineamientos prácticos. Ministerio de Salud de la Nación. 2019

Ceriani Cernadas, J.M.; Mariani, G.; Lupo, E.A.; Jenik, A, Neonatología Práctica. 5ta edición, Editorial Panamericana. 2018

Coto Cotallo GD; López Sastre J.; Fernández Colomer, B.; Álvarez Caro, F.; Ibáñez Fernández, A. Recién nacido a término con dificultad respiratoria: enfoque diagnóstico y terapéutico. Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la Asociación Española de Pediatría: Neonatología. 2008

González Armengod. C.; Omaña Alonso. M.C. Protocolos de Neonatología: Síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina, Servicio de Pediatría. Unidad de Neonatología. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. BOL PEDIATR 2006; 46(SUPL. 1): 160-165.

***Dr. Eduardo Ariel Otero**

Revisor

Médico Especialista en Neonatología. Jefe de Servicio de Neonatología del Hospital Isidoro G. Iriarte. Instructor de Residentes de Neonatología del Hospital Isidoro G. Iriarte.

a. TERMORREGULACIÓN EN EL RECIÉN NACIDO

b. RECIÉN NACIDO FEBRIL

Hospital Héctor Cura de Olavarría. Residencia Pediátrica



Dra. Anabella Coronel

Dra. Daiana Gallo

Dra. Jesica Menón

Dr. Gabriel Teuly

Residentes de Pediatría

Dra. Alejandra Capriata

Experta revisora

Termorregulación en el recién nacido

Sumario

El cambio que significa para el feto pasar de un ambiente cálido, confortable, como el intrauterino, a otro luminoso con temperatura inferior, lo obliga a una adaptación no sólo cardiopulmonar sino también de su temperatura corporal ya que si el ambiente térmico que lo rodea se altera, deberá aumentar su gasto metabólico y el consumo de oxígeno para poder mantenerse normotérmico. Esto es lo que se conoce como Termorregulación (equilibrio entre producción y pérdida de calor)

Introducción

Valores normales de temperatura en el recién nacido a término (OMS 1997)

Temperatura corporal central normal: Se considera a la temperatura axilar y rectal. El valor

normal es de 36,5 - 37,5 °C.

Temperatura de piel: Se considera a la temperatura abdominal. El valor normal es de 36,0 - 36,5 °C), de acuerdo a Academia Americana de Pediatría (AAP).

Dentro de la regulación térmica encontramos 3 componentes

Producción de calor

- ✓ Debe ser igual a la pérdida
- ✓ Se logra por tres mecanismos
 - Actividad muscular voluntaria
 - Actividad muscular involuntaria (escalofríos, temblores)
 - Termogénesis no dependiente de la actividad muscular: el más importante permitiéndole al RN sano y de término regular su temperatura aun en ambientes no térmicamente neutros.
- ✓ Depende de la actividad de una sustancia abundante en el RN de término que se llama Grasa Parda que representa un 2-6%

del peso corporal distribuida en: Cuello, Mediastino posterior, Zona interescapular, Zonas perirrenales y alrededor de las glándulas suprarrenales, tejido metabólicamente activo, con gran cantidad de vacuolas de grasa y extensamente vascularizado.

Los prematuros son los más vulnerables en su regulación térmica por menor actividad muscular (voluntaria-involuntaria) sumada a escasa Grasa Parda

Pérdida de calor

Consta de 2 etapas:

- Gradiente interno (desde el interior del cuerpo hacia la superficie)
- Gradiente externo (desde la superficie cutánea hacia el ambiente)

Existen 4 mecanismos por los que un cuerpo puede perder calor:

Conducción

Convección

Evaporación

Radiación

Alteración de la Termorregulación

Cuando los mecanismos de regulación térmica dejan de resultar eficaces, el organismo no puede mantener la temperatura en límites normales dando como consecuencia:

Hipotermia ($T^{\circ} < 36^{\circ}\text{C}$) más frecuente en neonatología con poco peso al nacer.

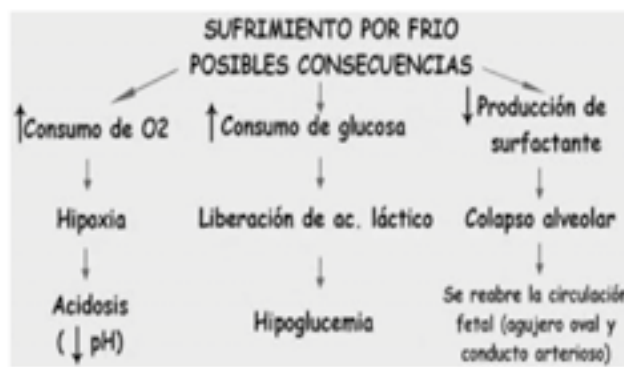
Las situaciones de mayor riesgo son:

- En sala de partos y en el lugar de recepción
- En el transporte dentro de una misma institución
- En procedimientos especiales

Se puede clasificar de acuerdo a su severidad.

- Leve: Temperatura corporal $\rightarrow 36 - 36,4^{\circ}\text{C}$. Temperatura de piel $\rightarrow 35,5 - 35,9^{\circ}\text{C}$
- Moderada: Temperatura corporal $\rightarrow 32 - 35,9^{\circ}\text{C}$. Temperatura de piel $\rightarrow 31,5 - 35,4^{\circ}\text{C}$
- Grave: Temperatura corporal de $< 32^{\circ}\text{C}$., Temperatura de piel $< 31,5^{\circ}\text{C}$

Clínica: Cuerpo frío al tacto Cianosis central y/o acrocianosis (existe después de las primeras



horas de vida), Aumento del requerimiento de oxígeno, Respiraciones irregulares y/o apnea / Taquipnea, Intolerancia alimentaria, Distensión abdominal, aumento del residuo gástrico, Bradicardia, Mala perfusión periférica, Disminución de la actividad Letárgia / Irritabilidad, Disminución de los reflejos, Hipotonía, Llanto débil, Sución débil, Hipoglucemia, Edema, Dificultad para descansar.

Técnica de recuperación del recién nacido hipotérmico en incubadora

- ✓ Si la temperatura del niño es menor de $36,5^{\circ}$, realizar el calentamiento lentamente entre $1^{\circ}-1,5^{\circ}\text{C}$ por hora. El rápido recalentamiento puede asociarse con mayores problemas orgánicos, metabólicos, cutáneos y cerebrales.
- ✓ Ajustar la temperatura de la incubadora $1-1,5^{\circ}\text{C}$ por encima de la temperatura axilar del niño.
- ✓ Retirar todos los elementos que puedan interferir con la ganancia de calor como sabanas plásticas, gorro y la vestimenta del recién nacido, hasta que la temperatura se normalice.
- ✓ Evitar las pérdidas de calor por cualquiera de los mecanismos: convección, radiación, conducción y evaporación.
- ✓ Monitorización de la temperatura axilar continua y control frecuente c/15 min., ajustando la temperatura de la incubadora a la temperatura axilar que vaya teniendo el niño.
- ✓ Si a pesar de lo expuesto anteriormente al niño le sigue bajando la temperatura axilar, es necesario buscar las fuentes de pérdida de calor y aumentar la temperatura ambiental de la incubadora a 37° . Valorar añadir un foco de calor radiante.

- ✓ La recuperación del paciente hipotérmico precisa de una vigilancia y un control estrecho por existir el riesgo de producir hipertermia.
- ✓ La hipotermia es “mala” pero la hipertermia es peor especialmente en RN con hipoxia, isquemia antes o después de nacer. Es fundamental evitar hipertermia inducida por los cuidados de enfermería.

Hipertermia ($T^{\circ} > 37.4^{\circ}\text{C}$), las situaciones que llevan a este estado son ambientes muy calurosos, exceso de abrigo, RN en incubadoras con temperaturas demasiado alta, RN en lumioterapia.

Clínica: Taquipnea, Apnea, Taquicardia, Hipotensión, Rubor, Extremidades calientes, Irritabilidad, Alimentación irregular, Letárgica, Hipotonía Postural en extensión, Llanto débil o ausente, Temperatura de piel mayor que central

Ante la presencia de un RN con hipertermia debemos de:

- ✓ Confirmar la Temperatura de la incubadora (adecuada al niño, a su edad y su situación). Situar la Temperatura en rangos de termoneutralidad.
- ✓ Si se está utilizando el modo de control de Temperatura “servo de piel”, confirmar que el sensor no se ha desplazado de su sitio. Confirmaremos que no tiene un foco de calor radiante adicional.
- ✓ Si el niño está en su “nidito” o vestido, procederemos a desvestirlo o sacarlo del nidito.
- ✓ Si es posible aumentaremos las pérdidas de calor por convección (abriremos alguna de las puertas de la incubadora).

En resumen, los factores relacionados con riesgo de alteración en la termorregulación son:

- ✓ Edad gestacional
- ✓ A menor edad gestacional, la postura es más deflexionada, presenta menor tono muscular, menor cantidad de depósitos de grasa parda, menor habilidad de generar calor por este mecanismo.
- ✓ Mayor área de superficie (relación masa-superficie) y menor cantidad de tejido celular subcutáneo
- ✓ Mayor pérdida de calor desde el interior del organismo por falta de aislamiento ya

que presenta epidermis fina y ausencia de estrato corneo en las primeras semanas de nacimiento (Las pérdidas por evaporación, por sí solas, pueden exceder la capacidad de producir calor)

- ✓ RN < 28-29 semanas: tienen dificultad para producir calor en respuesta al frío, necesitan temperaturas medioambientales elevadas, más altas cuanto menor es el peso del niño al nacimiento. Durante las primeras 48 h de vida estos niños tienen una respuesta vasomotora muy pobre ante una situación de frío y permanecen vasodilatados lo que aumenta las pérdidas de calor.
- ✓ RN > 29-30 semanas de EG (comparados con el grupo anterior) tienen mayor capacidad de aumentar o disminuir la producción de calor con objeto de mantener su temperatura corporal a pesar de las variaciones de temperatura de su entorno, pero igual tienen riesgo de alteraciones de la termorregulación.

Hipoxia e hipoglucemia

- Interfieren en la producción de calor en el pretérmino
- Son una consecuencia cuando utiliza el mecanismo metabólico para corregir la hipotermia.
- Anomalías congénitas
- Implican apertura en la piel como las gastrosquisis, onfalocele, extrofia vesical, meningocele, también favorecen la hipotermia.
- Daño del sistema nervioso central
- Puede interferir con su capacidad termorreguladora
- Retardo de crecimiento intrauterino
- Sedación

Valoración de la temperatura en el recién nacido

Según las recomendaciones de organismos internacionales los termómetros de mercurio no deben ser utilizados porque es un contaminante peligroso para el medio ambiente (Sociedad Canadiense de Pediatría, CEE, Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, 2006), y su medición precisa requiere 3-4 min.

Diferentes estudios indican que las diferencias entre los diferentes instrumentos no son significativas. Actualmente se aconsejan termómetros digitales usándolos según recomendaciones del fabricante.

La temperatura rectal quedaría restringida exclusivamente para casos de hipotermia moderada-grave. Esta temperatura puede verse afectada por la profundidad de la medición (punta del instrumento de medida no más de 2-2,5 cm en RNT), las condiciones locales que afectan el flujo sanguíneo y la presencia de materia fecal.

Además puede conllevar riesgos como la perforación de recto (No fuerce la inserción e introduzca solo la ampolla) y la capacidad de propagar contaminantes que se encuentran en las heces.

La temperatura timpánica no está indicada en el RN debido a la dificultad de lecturas por la posición del conducto auditivo externo.

Monitorización de la temperatura con los sensores de temperatura de la incubadora o de la cuna de calor radiante, los sensores tienen que estar bien adheridos a la piel, sobre una superficie lisa, no ósea, procurando no cubrir el sensor con ropa o pañal, y no recostando al niño sobre el sensor.

Manejo del ambiente térmico del RN

- ✓ Condiciones ambientales en Sala de Partos T° 27 – 28 °C.
- ✓ Atención inmediata en cuna con calor radiante.
- ✓ Secarlo y envolverlo en paños tibios. El RN puede perder por evaporación hasta 0,3 °C x minuto en la T° cutánea).
- ✓ Favorecer el contacto con su madre (piel a piel) para evitar pérdidas calóricas (mientras se produce el alumbramiento).
- ✓ Vestirlo: usar en lo posible gorro de algodón para prevenir pérdidas significativas de calor a través del cuero cabelludo.
- ✓ Traslado con su madre y control de T°, especialmente durante el periodo de transición (Rango de T° axilar normal entre 36,5 y 37 °C)

b. Recién nacido febril

Dra. Alejandra Capriata
Experta revisora

Fiebre en un lactante de 18 días de vida

Situación clínica

Indiana de 18 días de vida, es traída por su madre a la guardia por presentar fiebre de 24 horas de evolución y dificultad para alimentarse.

Al examen físico se encontraba irritable y se constatan signos vitales. FC 170 por minuto, FR 68 por minuto, SO₂ 100%. Tiraje subcostal, y espiración prolongada; relleno capilar conservado, pulsos distales presentes y simétricos.

Antecedentes: RNT de 37 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, apgar 9/10, serologías negativas, sin antecedentes perinatales de riesgo. Alimentada con lactancia materna exclusiva.

Su vivienda no consta de las necesidades básicas, conviviendo con ambos padres y hermanos de 3 años y otro de 1 año y medio.

Se solicita: análisis de laboratorio en el cuál se observa leucocitosis a predominio linfocitario, y reactantes de fase aguda aumentados. Función renal conservada. Y estado ácido base con PH7.35, PCO₂ 54.9, HCO₃⁻: 29. EB 2.8. Radiografía de tórax en la cual se observa condensación de vértice derecho, Hemocultivos por dos y urocultivo.

Reflexiones

- ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?
- ¿Hubieran solicitado algún otro estudio complementario?

La presencia de fiebre en menores de 1 mes nos obliga a buscar la causa de la misma. A pesar de que la etiología más frecuente es la de causa viral, estamos obligados a buscar signos de infección bacteriana grave, teniendo en cuenta, además, que aunque se encuentre estable al momento de la consulta, puede llegar a evolucionar rápidamente. Es necesario internar estos pacientes en una unidad de cuidados neonatales, y buscar el foco del cuál proviene la fiebre.

En este caso en particular, el paciente además de presentar registros febriles, presentaba taquipnea, taquicardia, tiraje subcostal, acidosis respiratoria sin academia y la imagen radiológica

ca de condensación, por lo que se lo interpreta como un cuadro de neumonía derecha.

Se decide su ingreso hospitalario y se indica tratamiento antibiótico con ampicilina 200 mg/kg/d c/ 6 hs EV, oxigenoterapia por cánula nasal a 1 litro.

Por la buena evolución clínica sin requerimiento de oxígeno, parámetros de laboratorio dentro de rangos normales, hemocultivos y urocultivo negativos, se decide su egreso hospitalario con pautas de alarma e indicaciones de medicación antibiótica vía oral.

Comentario

La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría.

Se considera fiebre cuando la temperatura axilar es superior a 37,5°C en forma persistente. En la bibliografía, se define fiebre a la temperatura rectal $\geq 38^\circ\text{C}$. Si bien su medición más fidedigna es esta última, conlleva riesgos y molestias, por lo que, habitualmente, se mide por la temperatura axilar. Se debe diferenciar de hipertermia por exceso de abrigo o por sobrecalentamiento, en el cuál la temperatura va a disminuir al retirar abrigo y disminuir la temperatura ambiental.

La fiebre sin foco (FSF), se define como aquella que dura menos de 5 días (aunque hay autores que amplían < 10 días esta definición), y cuya etiología no aparece tras una adecuada historia clínica y una exhaustiva y minuciosa exploración física. En aproximadamente 20% de los casos, no se encontrará causa evidente al inicio del cuadro.

Termorregulación en el recién nacido

El cambio que significa para el feto pasar de un ambiente cálido, confortable, como el intrauterino, a otro luminoso con temperatura inferior, lo obliga a una adaptación no sólo cardiopulmonar sino también de su temperatura corporal, ya que si el ambiente térmico que lo rodea se altera, deberá aumentar su gasto metabólico y el consumo de oxígeno para poder mantenerse normotérmico. Esto es lo que se conoce como Termorregulación (equilibrio entre producción y pérdida de calor).

Dentro de la regulación térmica encontramos 3 componentes:

Producción de calor: Se logra por tres mecanismos:

- Actividad muscular
- Actividad muscular involuntaria (escalofríos, temblores)
- Termogénesis no dependiente de la actividad muscular: el más importante permitiéndole al RN sano y de término regular su temperatura aun en ambientes no térmicamente neutros.

Esta producción de calor depende de la actividad de una sustancia abundante en el RN de término que se llama Grasa Parda (representa un 2-6% del peso corporal), que se encuentra distribuida en: Cuello, Mediastino posterior, Zona interescapular, Zonas perirrenales y alrededor de las glándulas suprarrenales.

Pérdida de calor: a través de 2 etapas: Gradiente interno (desde el interior del cuerpo hacia la superficie) y Gradiente externo (desde la superficie cutánea hacia el ambiente)

Existen 4 mecanismos físicos por los que un cuerpo puede perder calor:

- ✓ **Conducción** Pérdida o ganancia de calor a través del contacto con sustancia fría o caliente. Valorar la temperatura de los objetos que tendrán contacto con el RN – precalentar
- ✓ **Convección** Pérdida o ganancia de calor hacia una corriente de aire o agua que envuelve al RN. Evitar corrientes de aire. Calentar oxígeno y aerosoles. Baños con temperatura de agua controlada
- ✓ **Evaporación** Pérdida de calor asociado a la exposición de la piel o sistema respiratorio a concentraciones bajas de humedad, asociado a las características de la piel del RN. Secado de la piel y mantenerla seca, utilización de humedad ambiente en incubadora según la EG y días de vida. Humidificar gases
- ✓ **Radiación** Pérdida de calor hacia un objeto más frío que no está en contacto con el niño. Interponer elementos que eviten esta pérdida. Precalentar la incubadora. Evitar cercanía a aires acondicionados y puertas

Alteración de la Termorregulación: Cuando los mecanismos de regulación térmica dejan de resultar eficaces, el organismo no puede mantener la temperatura en límites normales.

Etiología de un síndrome febril

Las causas más frecuentes de fiebre en el primer mes de vida son las infecciones virales, representando más del 80% de los casos, siendo los enterovirus, rotavirus, VSR y adenovirus los primeros en la lista.

Teniendo en cuenta que los enterovirus son los más frecuentes, podemos asumir que va a haber una mayor prevalencia en los meses de primavera y verano, siendo las fuentes de contagio los miembros de la familia.

En segundo lugar se encuentran las causas bacterianas, las cuales generalmente encontraremos las procedentes del canal del parto por transmisión vertical (TV), como estreptococo del grupo B (SGB) o *S. agalactiae*, *E. coli*, enterococos y *L. monocytogenes*.

Con el abordaje actual de la colonización por SGB, ha disminuido el número de infecciones causadas por ella y, secundariamente, por *Listeria*, que casi ha desaparecido por TV.

Actualmente *E. coli* es la bacteria más frecuentemente aislada en sangre (60%) y orina (87%). (1)

Impresión clínica inicial

Es lo que nos permite reconocer un RN séptico, y así adoptar conductas terapéuticas sin pérdida de tiempo: se debe internar el paciente, efectuar los cultivos (sangre, orina y LCR), e indicar antibióticoterapia. De no poder obtenerse muestra de LCR y/o orina, no se debe retrasar el inicio del antibiótico, más si el paciente luce séptico.

La expresividad clínica es muy variable según la edad, y en los menores de 3 meses, sobre todo neonatos, es escasa. Pueden presentar síntomas inespecíficos como letargia, rechazo de alimentación, vómitos, llanto inconsolable o irritabilidad.

Interrogatorio

Es de importancia conocer los antecedentes personales de los primeros días de vida, del periodo perinatal, y antecedentes maternos; y detalles del cuadro clínico actual.

De los antecedentes maternos, es de importancia conocer si hubo infección cercana al parto, o si presentó colonización vaginal por *Estreptococo* del grupo B, como así también las serologías.

Si concurre a guardería, estado de inmuniza-

ción, contactos enfermos en el hogar, son otro de los datos a recabar. También es de suma importancia saber si en los primeros días de vida, el RN estuvo hospitalizado y si requirió o no la colocación de Vías venosas durante la misma, ya que aumenta el riesgo de infecciones intra-hospitalarias.

Observación y examen físico

Comenzar con la toma de la temperatura y así evaluar si puede tratarse de un cuadro febril o de hipertermia por sobrecalentamiento. Realizar el control del resto de signos vitales como: oximetría de pulso, frecuencia cardíaca (FC), respiratoria (FR).

Lo importante a observar es si calma el llanto o la irritabilidad en brazos de la madre, si duerme intranquilo o no logra conciliar el sueño, se si alimenta bien o lo hace débilmente, o lo rechaza.

En cuanto el examen físico a realizar: Auscultación pulmonar cuidadosa (los signos respiratorios se van instalando paulatinamente, primero la presencia de taquipnea, y aleteo nasal, y luego los ruidos respiratorios); otoscopía (siempre se debe realizar, sobre todo ante aquellos bebés muy irritables y con llanto inusual); examen óseo, de articulaciones y tono muscular; examen de la piel y del relleno capilar (evaluar mediante el tacto si las extremidades se encuentran frías en contraposición con el resto del cuerpo; esto es un signo de infección bacteriana grave, más aún si el relleno capilar se encuentra enlentecido).

Estudios auxiliares

- Hemograma completo con recuento diferencial de leucocitos: la leucopenia, y en especial la neutropenia tiene un alto valor predictivo de IBG, no tanto así la leucocitosis $> 20.000 /\text{mm}^3$. La relación de neutrófilos totales/neutrófilos inmaduros (NI/NT) mayor de 2 es sugestivo de infección.
- Reactantes de fase aguda: la PCR aumenta sus valores después de 8 a 12 horas de que inicia el cuadro infeccioso. También se puede utilizar la pro calcitonina (PCT) siendo su sensibilidad ligeramente superior a la PCR a la hora de predecir IBG, pero, sobre todo, es útil porque se eleva más rápidamente.
- Hemocultivos, antes de iniciar tratamiento antibiótico empírico.
- Cultivos de LCR: único método que nos va a

permitir diagnosticar meningitis. La tinción de GRAM y el examen citoquímico son técnicas coadyuvantes. Desterrada prácticamente de la batería de pruebas rutinarias salvo en niños con clínica o exploración sugestiva de meningitis o encefalitis, o en cualquier lactante menor de 3 meses que no cumpla los criterios de bajo riesgo

- Cultivos de Orina: es de suma importancia ya que es la infección bacteriana más frecuente en el período neonatal. Se pueden agregar tiras reactivas en orina.

- Imágenes: La RX de tórax sólo se debe solicitar ante signos clínicos respiratorios como taquipnea y aleteo nasal, tiraje intercostal y quejido. Recomendada en sospechas de neumonía oculta, con fiebre de $>39-40^{\circ}\text{C}$ (dependiendo del autor) y leucocitosis $\geq 20000/\text{mm}$.

Criterios de predicción de Infección bacteriana Grave en menores de 3 meses con fiebre:

- Bajo riesgo Alto riesgo
- Orina: Rto de GB <5 por cpo >5
- RGB en sangre 4100 a < 20.000
 <4100 o > 20.000
- T° rectal $<39.6^{\circ}\text{C}$ $>39.6^{\circ}\text{C}$
- Edad > 13 días < 13 día

Otra forma de predecir el bajo riesgo de IBG es considerar:

- Más de 35 semanas de gestación
- Sin enfermedades crónicas
- Sin hospitalizaciones previas
- Sin antibióticos en el período perinatal
- Sin antibióticos dentro de los últimos 7 días
- Adecuado aspecto clínico
- Sin infección focal
- Laboratorio: GB entre 5.000 y 15.000, LCR < 5 leucocitos/ mm^3 y sin gérmenes en el Gram, Orina: leucocitos $< 9/\text{mm}^3$, sin gérmenes en el directo.
- RX de tórax normal en lactantes con signos respiratorios.

Conducta clínica

Varios indican la internación de todos los bebés menores de 1 mes con fiebre sin foco aparente. Otros, de no haber signos de IBG, se podrían realizar controles por ambulatorio de forma estricta. El primer control, no debería realizarse más allá de las 12 horas para poder determinar el estado clínico del bebé.

Tratamiento

El hecho de internar a un neonato, no significa que requiera del uso de antibióticos. Sólo se puede justificar en los RN que se internan en los primeros 15 días de vida y tengan algún antecedente de riesgo o algún factor que incremente la sospecha de IBG.

- ✓ El inicio del tratamiento antibiótico empírico inicial no debe demorarse en pacientes en mal estado general y con alto riesgo de IBG por antecedentes (prematuridad, internación prolongada en neonatología u hospitalización anterior, tratamiento antibiótico previo o actual, enfermedad de base, ictericia sin causa definida, madre con cultivo positivo para estreptococo grupo B o exámenes complementarios anormales. (2)
- ✓ En cuanto a los Antibióticos a utilizar con mayor frecuencia son ampicilina/gentamicina, ampicilina/amikacina, amikacina/vancomicina o amikacina/cefazolina. La duración va a depender de cuál sea la infección a tratar.
- ✓ Si en la consulta inicial su estado general no es bueno: Internación, cultivos y antibióticos
- ✓ En menores de 14 días: Internación, cultivos, y estudios de laboratorio. Antibióticos no más de 48-72 horas si los cultivos son negativos y presenta buen estado general
- ✓ En mayores de 15 días con buen aspecto clínico y LCR normal: Internación sin antibióticos o control ambulatorio en 12 horas
- ✓ RN febril sin foco Realizar PL por ser la infección más grave
- ✓ Si CLR muestra > 10 GB, aún con Gram negativo: Internación y antibióticos hasta resultado de cultivos
- ✓ Si en la orina se observa > 10 GB por cpo o gérmenes en el directo: Internación y antibióticos
- ✓ Si taquipnea + aleteo nasal: Internación, control de saturación y RX de tórax.
- ✓ Si la RX muestra infiltrado difuso, más del 95% son de causa viral: No indicar ATB

Bibliografía

-

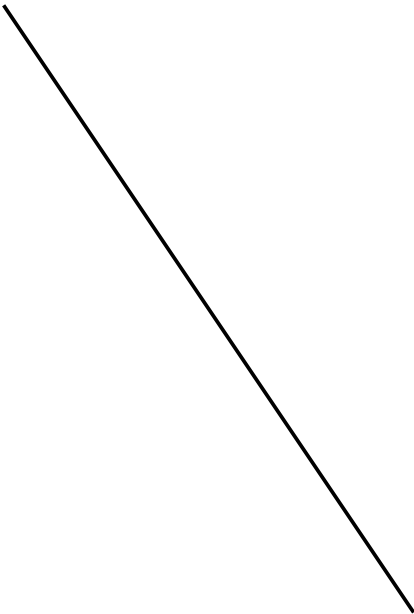
Ares J, Pontevedra. F. Manejo del paciente pediátrico con fiebre sin foco .17 Congreso en actualización pediátrica.
Ceriani Cernadas. Regulación de la Temperatura corporal en el recién

nacido y el medio ambiente en las unidades neonatales. Cap 9. Neonatología Práctica. Cuarta edición, Año 2009.

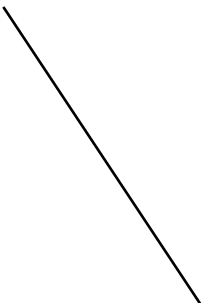
Fausto M., Ferollaa F. Consenso para el uso adecuado de antibióticos en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco de infección evidente. Arch Argent Pediatr 2017

Franco E, Fuenzalida O. Termorregulación y Humedad en el Recién Nacido.

Quiroga A, Chattas G. Guía de Práctica Clínica de Termorregulación en el Recién Nacido. 2010.



NÚCLEO SITUACIONES CLÍNICAS



Categoría **B**

SIBILANCIAS RECURRENTES EN EL NIÑO MENOR DE 3 AÑOS

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Lucio Meléndez” de Adrogué



Dra. Sonia A Batiuk

Dra. María Agustina Lagomarsino

Ex Residentes de clínica pediátrica. Médicas internas

Dra. María de la Paz Ferrín

Jefa de Residentes

Dr. Nicolás Cora

Jefe de Servicio

Dr. Juan Gagneten*

Dr. Luciano Alva Grimaldi**

Expertos revisores

Sumario

La prevalencia de la obstrucción bronquial del lactante y el niño pequeño es del 50% por debajo de los 3 años de edad. La misma disminuye a cifras del 30% en niños de 5 años. Esta patología representa el 25% de las admisiones hospitalarias, alcanzando cifras de hasta el 50% en períodos invernales. La tasa global de recurrencia de sibilancias postbronquiolitis oscila entre el 40 a 60% (HRB posviral).

Se analiza las terapéuticas recomendadas para este síndrome prevalente en la edad pediátrica, luego de una revisión de su fisiopatología, de sus diagnósticos diferenciales y sus formas clínicas.

Caso Clínico

Broncoobstrucción (BO) a repetición que requiere múltiples internaciones.

Situación clínica

Paciente de 2 años de edad con BO a repetición desde los 2 meses de vida. En seguimiento con su pediatra de cabecera; luego de su 3° episodio de BO inició tratamiento controlador a los 7 meses, con Budesonide 800mcg/día con espaciador. A los 15 meses de vida, presenta episodio bronquial severo que requiere su internación con O2 suplementario (VSNF + Adenovirus y posterior pase a UCIP por 5 días, con requerimiento de ARM. Cursó con una reagudización respiratoria con VSNF + Influenza B. Evoluciona favorablemente hasta el alta. Durante 2 meses posteriores a la internación persistió con broncoespasmos con tratamiento ambulatorio con B2 y corticoides vía oral en forma intermitente, con seguimiento por Unidad Sanitaria, para luego reinternarse a los 17 meses por reagudiza-

ción respiratoria con aislamiento en SNF de Metapneumovirus, con requerimiento de oxígeno por 12 días.

Antecedentes Personales

RNT (40 Semanas) / G3P3/ PAEG (3500) / Apgar 9/10. Embarazo controlado. Parto vaginal, cefálico. Nació en HLMA. Serologías maternas negativas 28/10/17. FEI: Normal. Vacunas completas para la edad, incluyendo la gripe.

Antecedentes Familiares

Mamá, y los 2 hermanos: Asmáticos.
Niegan tabaquismo.

Examen físico

Eutrófico, leve taquipnea (FR 30 x min), buena entrada de aire bilateral con rales subcrepitan-tes bilaterales, espiración prolongada, rinorrea, eccema en pliegues (piel atópica). FC 120 x min, 2 ruidos en 4 focos, soplo sistólico (funcional) P 12 K (P25) T 86 cm (P 25-50).

Enfoque del paciente

¿Qué exámenes complementarios son necesarios?
¿Qué diagnósticos diferenciales surgen?
¿Considera modificar su tratamiento? ¿Qué conducta tomaría?
¿Estamos ante una enfermedad pulmonar crónica pos viral?

La anamnesis y el examen físico constituyen la base para la orientación diagnóstica, nuestro paciente refiere antecedentes de atopia familiar (asma en los padres), y al examen físico eccema atópico, con agresiones virales desde los primeros meses de vida, que lo llevan a requerir ARM por 5 días.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de asma comienzan durante los primeros años de vida, la identificación de niños pequeños con alto riesgo de desarrollar la enfermedad es importante para la salud pública.

Se le solicitaron los estudios de laboratorio y Rx Tórax (F y P) siendo los resultados destacables:

- GB: 11200 (0, 19, 20, 0, 51,10) GR: 5160000
Hb: 10.08 Hto: 34 VCM: 65 HCM: 19.5
CHCM: 30 PLT: 463000.
- Se interpreta como anemia Microcítica Hipocrómica, eosinofilia moderada

- Saturación de transferrina: 5% valor normal (20-50)
- Ferritina: 9.30 valor normal (12-200)
- TIBC: 442 valor normal (250-425)
- Cortisol matutino en suero: 0.2
- Ig E 984 UI, Ig A, G y M dentro de límites normales.
- Rx Tórax (F y P): Dentro de límites normales
- PPD 2UT: 0 mm.

Utilizando el Índice de riesgo para el desarrollo de asma (API), descrito por Castro-Rodríguez y col, en el 2000, sobre la cohorte de Tucson, que dice que un paciente además de presentar al menos 3 episodios de sibilancias durante los primeros 3 años de vida y un factor de riesgo principal (antecedentes parentales de asma o eccema) o dos de los tres factores de riesgo menores (eosinofilia mayor o igual a 4%, sibilancias sin resfríos y rinitis alérgica). El riesgo de tener asma aumenta a 9.3 veces cuando se utiliza el API. Más del 95% de los niños con un API negativo no desarrollan asma activa a los 6 y a los 13 años. Por lo tanto tenemos un Índice en base a la clínica para predecir el desarrollo posterior de asma.

Debido a la complejidad de nuestro paciente, por sus múltiples internaciones y obstrucciones bronquiales recurrentes y persistentes, presenta una supresión del eje cortico-suprarrenal, anemia y eosinofilia.

Durante las siguientes consultas, se fue adecuando el tratamiento controlador (aerocámara valvulada, técnica inhalatoria, adherencia al tratamiento, budesonide o fluticasona y montelukast), corticoides por vía oral para regularizar la supresión adrenal, sulfato ferroso.

Se solicitaron:

- ✓ Serologías para toxocara canis: Negativo
- ✓ Parasitológico en materia fecal en fresco y seriado y test de Graham: Negativo
- ✓ Seriado esófago gastroduodenal: no evidencia fístulas, estenosis ni reflujo gastroesfágico
- ✓ Test del sudor: Normal, a pesar de que nuestro paciente presenta un buen crecimiento ponderal, el 15% de los fibroquísticos tienen suficiencia pancreática, por lo tanto, un desarrollo ponderal dentro de límites normales.

Luego de 1 año de seguimiento y debido a que persistían periodos de OB prolongados y severos se le realizó una TAC tórax de alta resolución para descartar bronquiectasias o aéreas de patrón en mosaico característico de la enfermedad pulmonar crónica posviral, debido a su antecedente severo de internación por adenovirus, que requirió ARM aunque por pocos días. El resultado de dicho estudio: Zonas de atrapamiento aéreo, sin otras particularidades. No evidenciando lesiones de enfermedad pulmonar crónica posviral,

Llegamos a la conclusión que nuestro paciente, luego de un período prolongado de seguimiento y estudio, presenta asma bronquial severo, en base a los antecedentes familiares de asma, y personales, eccema, eosinofilia, OB severas con requerimiento de internaciones, OB frecuentes y prolongadas en el seguimiento ambulatorio. Luego de descartar múltiples enfermedades.

No resulta nada fácil encarar los estudios de un lactante/ preescolar con OB severas o recurrentes, así lo demuestra un comité de expertos de la American Thoracic Society, donde le seleccionaron preguntas clínicas relacionadas con incertidumbres o controversias en la evaluación diagnóstica de los niños con sibilancias recurrentes o persistentes. A pesar de que las sibilancias infantiles es un problema común, no existen pautas para la evaluación de los lactantes con sibilancias recurrentes o persistentes que no se alivian ni previenen con las terapias estándar y concluyen que hay poca evidencia para guiar a los médicos en la selección de pruebas de diagnóstico para sibilancias recurrentes o persistentes.

Sibilancias Recurrentes en el niño menor de 3 años

Definición

El síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR) es el conjunto de manifestaciones clínicas obtenidas por la obstrucción bronquial con exacerbaciones o persistente (de la vía respiratoria intratorácica) en los niños menores de 3 años de edad, caracterizada por: tos, espiración prolongada y SIBILANCIAS-

La presentación de más de tres episodios de obstrucción bronquial en un año, durante los 3 primeros años de vida se denomina "Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR/ lac-

tante-preescolar sibilante).

Epidemiología

La prevalencia de la obstrucción bronquial del lactante y el niño pequeño es del 50% por debajo de los 3 años de edad. La misma disminuye a cifras del 30% en niños de 5 años. Esta patología representa el 25% de las admisiones hospitalarias, alcanzando cifras de hasta el 50% en períodos invernales.

La tasa global de recurrencia de sibilancias postbronquiolitis oscila entre el 40 a 60% (HRB posviral).

Factores predisponentes

- Bronquios de menor calibre con mayor resistencia al flujo aéreo.
- Disbalance entre los linfocitos Th 1 y Th2, a favor de éstos últimos.
- Virus. HRB adquirida.
- HRB congénita.
- Factores medioambientales.

Planteos diagnósticos

Las causas más frecuentes son:

- ✓ Bronquiolitis a repetición (sibilante transitorio).
- ✓ Asma y sus fenotipos
- ✓ Fibrosis quística.
- ✓ Displasia broncopulmonar.
- ✓ Enfermedad pulmonar crónica posinfecciosa (Bronquiolitis obliterante).
- ✓ Reflujo gastro-esofágico.
- ✓ Fístula traqueoesofágica.
- ✓ Anillos vasculares.
- ✓ Traqueo/broncomalacia.
- ✓ Cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar.
- ✓ Compresiones extrínsecas de la pared bronquial secundarias a tumores, adenomegalias y quistes broncogénicos.

Cuadros clínicos que se presentan con sibilancias

Bronquiolitis a repetición (sibilante transitorio)

Presentan episodios de sibilancias recurrentes que se normalizan antes de los 3 años con independencia de las intervenciones terapéuticas realizadas. No tienen antecedentes familiares de

asma ni sensibilización alérgica. Presentan flujo espiratorio máximo ajustado por longitud a la capacidad residual funcional [V sub maxFRC] tanto en los primeros meses de vida y a los 6 años. Se correlaciona con las madres que fumaban.

Ante cualquier infección respiratoria, desencadena una obstrucción bronquial.

A medida que sus vías respiratorias crecen en tamaño absoluto con la edad, estos niños pueden volverse menos propensos a tener sibilancias durante las infecciones virales.

Asma

Es una enfermedad heterogénea, caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea, asociado a hiperreactividad bronquial que ante estímulos desencadenantes produce episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos; debidos a la obstrucción bronquial de grado y duración variable, reversible en forma espontánea o mediante tratamiento. La atopía habitualmente está presente en los pacientes asmáticos, pero no está en la definición porque hay un porcentaje que no lo presenta.

Hay distintos fenotipos de asma, en la cohorte de Tucson, Martinez y col, describieron 3 tipos de sibilantes:

- ✓ Transitorio (arriba descripto)
- ✓ Sibilante tardío que comienza después de los 3 años y persiste sibilando hasta después de los 6 años. Se encuentra relacionada con los estímulos virales (ej. pos VSR). Los niños con sibilancias de inicio tardío fueron significativamente más propensos que aquellos que nunca tuvieron sibilancias a tener madres con asma, ser varones y haber tenido rinitis en el primer año de vida. La función pulmonar al nacer y a los 6 años se mantiene dentro de límites normales. A los 6 años presentaban una IgE normal o mínimamente elevada, pero sí tenían IgE específica contra el VSR en las secreciones nasales.
- ✓ Sibilante persistente, comienzan a presentar sibilancias desde el primer año de vida y persiste más allá de los 6 años. El asma materna, el tabaquismo materno, la rinitis, además de los resfriados, el eccema durante el primer año de vida, el sexo masculino y el origen étnico hispano se asociaron de forma independiente con

las sibilancias persistentes. Estos pacientes presentan función pulmonar normal al nacer y a los 6 años presentan un deterioro de la misma. Los niños con sibilancias persistentes tuvieron síntomas más frecuentes durante el primer año de vida que aquellos con sibilancias tempranas transitorias.

Otros fenotipos según la ERS (European Respiratory Society, 2008), basada en los síntomas

Sibilante episódica viral: Estacional, asociada a IRA alta, de corta duración y asintomático inter crisis.

Sibilante multigatillado: Desencadenado por múltiples estímulos, ej, ejercicio, risa, llanto y sueño, con síntomas entre los episodios.

El inicio del tratamiento deberá determinarse en función de la intensidad y de la frecuencia de los síntomas, con el objetivo de disminuir la morbilidad y aumentar la calidad de vida del paciente. NAEPP Expert Panel Report 3 (National Asthma Education and Prevention Program, Third Expert Panel on the Diagnosis and Management of Asthma, considera que el tratamiento de control debe iniciarse en: Lactantes y niños pequeños que requieran tratamiento sintomático, al menos 2 días a la semana durante más de 1 mes, que hayan tenido dos exacerbaciones con requerimiento de corticoides sistémicos en los 6 meses anteriores, 4 o más episodios de sibilancias en el año previo con API positivo.

Fibrosis quística

La FQ es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, caracterizada por la disfunción de las glándulas de secreción exócrina. En los niños pequeños es habitual la tos seca y recurrente, y en el examen físico suele hallarse taquipnea persistente, aumento leve del diámetro antero posterior del tórax disminución de la expansión torácica, persistencia de retracción intercostal y obstrucción bronquial.

Es relativamente frecuente el diagnóstico de “bronquiolitis obstructiva bronquial recurrente con mala respuesta al tratamiento”. Se sospecha de FQ cuando existe enfermedad pulmonar crónica, anomalías gastrointestinales o nutricionales, síndrome de pérdida de sal,

hermano/a con FQ o pesquisa neonatal positiva. Se confirma con 2 test el sudor positivo (Cl mayor de 60meq/l y un peso mínimo de 100mg) y/o estudio genético positivo.

Displasia Bronco pulmonar (DBP)

La DBP es una complicación del prematuro, que se caracteriza por daño y alteración del desarrollo pulmonar. Se describe la DBP clásica en la que predominaba el daño por ventilación a presión positiva y altas concentraciones de oxígeno, y con el advenimiento de la nueva tecnología (menos agresión en la ventilación), uso de corticoides antenatales, surfactante posnatal dio paso a la Nueva DBP que se presenta en niños más inmaduros, con poco desarrollo canalicular, alveolos más grandes, menos fibrosis pulmonar y menos grado de HTP. La DBP es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente del lactante; presenta una importante morbilidad en los primeros años de vida e implica un riesgo de lesión pulmonar a largo plazo. La DBP se manifestará de acuerdo con el tipo y la gravedad de la lesión pulmonar. La mayoría de los niños con DBP mejoran y están asintomáticos en el momento del alta hospitalaria.

Las manifestaciones clínicas son: episodios de sibilancias recurrentes, hiperreactividad bronquial, tos persistente, taquipnea e insuficiencia respiratoria, con mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Falla de medro. En un gran número de niños pueden coexistir ambos patrones.

Síndromes aspirativos

Definidos como la aspiración de sustancias extrañas hacia el árbol traqueo bronquial que puede presentarse como un evento agudo y único o como un síndrome recurrente crónico. Esto puede ocurrir durante la alimentación o bien, después de la misma por RGE.

Reflujo gastro- esofágico

Es el pasaje del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación y vómitos, es la causa más frecuente de síndromes aspirativos en la edad pediátrica.

Los niños con esta patología pueden presentar signos y síntomas digestivos como vómitos, regurgitación, irritabilidad, cólicos, epigastralgia, rumiación, hipo, dolor retroesternal y distensión

abdominal

A nivel respiratorio puede provocar broncoaspiración e hiperreactividad de la vía aérea. La magnitud del daño provocado por la aspiración dependerá de las características cuali y cuantitativas del material aspirado, así un $\text{pH} < 7,35$ incrementará el daño, alcanzando su máxima capacidad de injuria con valores de 1,5.

En cuanto al volumen, la aspiración equivalente a 1ml/kg de material ácido produce daño leve, mientras que si el volumen es de 2ml/kg las lesiones serán graves y eventualmente mortales. La acidificación del esófago produce una hiperreactividad bronquial (OB) a través del nervio vago.

Fístula traqueo esofágica (FTE)

Existen 5 tipos de FTE: con atresia esofágica (AE) o sin ella.

1: Atresia esofágica con FTE distal (la más frecuente): El segmento superior del esófago termina en una bolsa ciega (AE) y el segmento inferior se une a la tráquea

2: Atresia Esofágica Aislada: Ambos segmentos del esófago terminan en puntos ciegos pero ninguno de estos segmentos está unido a la tráquea. La atresia de esófago aislada se presenta en el (8 %) de los casos.

3: Fístula traqueo esofágica aislada: No existe atresia de esófago porque el esófago se continúa hasta el estómago. Sin embargo, existe una fístula entre el esófago y la tráquea. También conocida como Fístula tipo H. Este tipo de fístula se asocia con menor frecuencia a otras anomalías. Cuando la fístula es larga y oblicua, es más difícil el diagnóstico. Los síntomas son mínimos y la fístula puede pasar inadvertida por muchos años.

4: Atresia esofágica con fístula traqueo esofágica proximal: El segmento superior del esófago forma una fístula hacia la tráquea (FTE). El segmento inferior del esófago termina en una bolsa ciega (AE). Esta es una forma muy rara de AE / FTE.

5: Atresia esofágica con fístula traqueo esofágica distal y proximal: Ambos segmentos del esófago, el distal y el proximal se encuentran unidos a la tráquea. Esta es la forma más rara de AE / FTE.

Se pone de manifiesto invariablemente en el período neonatal, excepto la fístula tipo H. Algunos neonatos luego de la resolución quirúrgica

gica siguen presentando complicaciones respiratorias agudas y crónicas asociadas al reflujo gastroesofágico secundario a la incompetencia del esfínter esofágico inferior, esto se debe a un defecto congénito de los plexos nerviosos intrínsecos de la tráquea y el esófago.

Trastornos de deglución

La respiración y la deglución están relacionadas anatómica y funcionalmente, tanto así, que durante la coordinación neuromuscular que permite la alimentación, se produce una breve interrupción de la respiración. Cuando existen trastornos en los procesos deglutorios, los niños pueden presentar tos al comer, retraso pondoestatural, agotamiento durante la alimentación, interurrencias respiratorias y pausas respiratorias durante la deglución con crisis de ahogo. Cuando existen trastornos en la deglución puede ocurrir la aspiración de material (saliva, líquidos o sólidos) a la vía aérea, pudiendo ocasionar en los casos masivos la muerte y en los casos de menor intensidad enfermedades agudas, crónicas o complicar procesos respiratorios coexistentes. Se sospecha por presencia de síntomas desde el nacimiento o en niños con compromiso neurológico (por enfermedad o bajo efecto de alguna medicación

Cuerpo extraño en la vía aérea

La aspiración de un cuerpo extraño en la vía aérea es un accidente que puede amenazar la vida de los niños. Los objetos aspirados pueden ser diversos y entre estos son frecuentes los de origen vegetal. El 80% de los cuerpos extraños son radiolúcidos. Los hallazgos clínicos podrán variar desde casos asintomáticos, con antecedentes de evento asfíctico, grave dificultad respiratoria, dependiendo de la localización y el grado de obstrucción de la vía aérea. El cuerpo extraño puede localizarse en tráquea o bronquios y pasada la fase aguda puede manifestarse con sibilancias, atelectasias intermitentes, neumonías recurrentes o síntomas obstructivos bronquiales atípicos que no mejora con el tratamiento.

Cardiopatías congénitas y anillos vasculares

Ante la presencia de cardiomegalias que puedan distorsionar la dirección de las ramificaciones bronquiales, los anillos vasculares o vasos

anómalos que puedan comprimir las paredes bronquiales, traqueales o bien anomalías que alteren el flujo sanguíneo pulmonar (cardiopatías con hiperflujo). Las manifestaciones clínicas respiratorias que podrán acompañarse o no de cianosis, taquicardia, falta de progresión de peso o hepatomegalia.

Disquinesia ciliar primaria

Se trata de una enfermedad autosómica recesiva heterogénea que afecta la motilidad ciliar y se manifiesta con enfermedades óticas, sinusales y pulmonares. El clearance mucociliar es un mecanismo de defensa primario innato y su defecto puede ponerse de manifiesto tempranamente en el neonato, presentado taquipnea, aumento del trabajo respiratorio y frecuentemente requerimiento de oxígeno suplementario por unas pocas horas o semanas. Los niños con disquinesia ciliar fundamentalmente presentan tos crónica, generalmente productiva, no suelen presentar sibilancias, y pueden tener neumonías recurrentes, atelectasias y posteriormente bronquiectasias. Algunos pacientes pueden presentar un compromiso obstructivo considerable.

El 50% de los situs inversus presentan disquinesia ciliar primaria.

Traqueo/ broncomalacia

Hay una debilidad de las paredes de la tráquea y/o bronquios (cartílago) que se colapsa durante la espiración o períodos de aumento de la presión intratorácica como en el llanto. Pueden estar asociadas a otras anomalías congénitas, como anillos vasculares, atresia duodenal o esofágica, laringomalacia o paladar hendido. La necrosis del cartílago puede ser por decúbito debido a la intubación o traumatismos. Esta debilidad en la pared de la vía aérea determina ineficiencia en el mecanismo de la tos, respiración ruidosa al llorar, retención de secreciones, neumonías recurrentes y bronquiectasias.,

Enfermedad pulmonar crónica postinfecciosa (EPCP)

Los pacientes con EPCP exhiben diversos cambios inflamatorios desde el inicio de la injuria, pudiendo evolucionar a la producción de lesiones secuelas de diversos tipos. La expresión

más grave es la bronquiolitis obliterante, que presenta una obstrucción crónica de la pequeña vía aérea sin respuesta a los broncodilatadores y disminución de la compliance pulmonar, en general es de etiología viral siendo el más frecuente el adenovirus, seguido por sarampión, mycoplasma pneumoniae, excepcionalmente VSR, Luego otras formas de lesiones pulmonares crónicas son: las bronquiectasias (las más frecuentes dentro la EPCP), Sd Swyer-James o McLeod y la neumonitis intersticial (la variante menos frecuente).

Hay un score clínico-radiológico para el diagnóstico de bronquiolitis obliterante posinfecciosa, siendo más específico que sensible. Un puntaje mayor de 7 tiene una especificidad del 100% y sensibilidad del 67%.

1: "Historia clínica típica": un paciente previamente sano, con un grave episodio de bronquiolitis, que desarrolla hipoxemia crónica ($\text{SaO}_2 < 92\%$) por más de 60 días (4 puntos).

2. "Antecedente de infección por adenovirus" (3 puntos).

3. "TCAR con patrón en mosaico" (4 puntos).

Inmunodeficiencias

La sintomatología respiratoria es la primera manifestación de una inmunodeficiencia primaria en el 70% de las ocasiones. En los niños menores de 3 años las infecciones respiratorias frecuentemente cursan con tos y sibilancias, posteriormente neumonía recurrente o atelectasia persistente. Infecciones por gérmenes inusuales. Otros signos y síntomas sugestivos son la presencia de infecciones recurrentes en piel, diarrea crónica, conjuntivitis crónica y reacciones inusuales ante las vacunas. Las Rx Tórax nos sirve para documentar las consolidaciones, y en el caso de que presenten lesiones persistentes localizadas o recurrentes una TAC de tórax de alta resolución nos ayudaría mejor a evaluar el parénquima pulmonar.

Tuberculosis

La tuberculosis primaria habitualmente se caracteriza por presentar formas neumoganglionares. Los síntomas respiratorios inicialmente son escasos, pero con el agrandamiento de los ganglios mediastínicos pueden hallarse signos y síntomas de compresión de la vía aérea como tos y sibilancias. Los lactantes y niños pequeños

tienen más probabilidades de presentar síntomas que persisten durante más de dos semanas sin mejorar con los tratamientos habituales. También suelen presentar fiebre, pérdida o progreso inadecuado de peso y decaimiento.

Evaluación del paciente con sibilancias recurrentes

Datos de la anamnesis

Edad de comienzo.

Antecedentes familiares relacionados.

Antecedentes personales vinculados a enfermedad respiratoria (prematurez, ARM).

Patología subyacente-comorbilidades.

Pautas de alimentación (lactancia materna, biberón acostado, suplementos vitamínicos).

Descripción de síntomas y signos asociados (tos, apneas, signos de atopía)

Factores desencadenantes, resolución de los episodios y síntomas entre las exacerbaciones.

Inmunizaciones recibidas.

Epidemiología y factores ambientales.

Tratamientos previos, respuesta a los mismos.

Examen físico

Antropometría (crecimiento y desarrollo).

Morfología torácica.

Hipocratismo digital.

Auscultación respiratoria (sibilancias, espiración prolongada).

Uso de músculos accesorios de la respiración.

Auscultación cardiovascular (ruidos cardíacos, soplos).

Estado de conciencia.

Estado de nutrición.

Técnica inhalatoria.

De acuerdo a los signos y síntomas asociados nos orientará al diagnóstico presuntivo

- Tos crónica.
- Hipocratismo digital.
- Hipoxemia crónica.
- Tos de aparición brusca y/o asfixia.
- Signos localizados.
- Apneas.
- Crisis de cianosis.
- Vómitos.
- Estridor.
- Soplo cardíaco.
- Desnutrición/Esteatorrea.
- Infecciones recurrentes.

- Alteraciones del sensorio.
- Signos de atopía.
- HRB.

Exámenes complementarios

Rx Tórax.
 PPD 2 UT.
 Hemograma completo, proteinograma electroforético, Ig A, G, M, E. Estudio inmunológico en caso de ser necesario.
 Test del Sudor.
 Esófagograma/SGD.
 Examen Cardiovascular: ECG y eventualmente ecocardiograma.
 EAB arterial y/o Oximetría de pulso.
 Tac Tórax de alta resolución con/sin contraste.

Bibliografía

-
Brand, P, et al. Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 Eur Respir J 2014; 43: 1172-1177.
Castro-Rodríguez, J A, et al. A Clinical Index to Define Risk of Asthma in Young Children with Recurrent Wheezing. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:1403-1406.
Clement L Ren, et al. Official American thoracic society clinical practice guidelines: Diagnosis evaluation of infants with recurrent or persistent wheezing. Am J Respir Crit Care Med 2016; 194:356-73.
Colom AJ, Teper AM. Clinical prediction rule to diagnose post-infectious bronchiolitis obliterans in children. Pediatr Pulmonol 2009; 44 (11):1065-9.
Comité Nacional de Neumonología, Sociedad Argentina de Pediatría. Bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Arch Argent Pediatr 2018; 116 Supl 3:548-558.
Global Initiative for Asthma 2018
Martínez, FD, et al. Asthma and weezing in the first six years of life. N Engl J Med 1995; 352:133-8.
Martínez, FD. Recognizing early asthma. Allergy 1999; 54(Suppl. 49):24-28.
Scigliano, S y col. La enfermedad sibilante en el lactante y en el niño pequeño. En: Enfermedades Respiratorias Pediátricas. Editores Macri CN, Teper AM. Buenos Aires: Mc Graw Hill, 2003:667-676.

*Dr. Juan Gagnetten

Neumólogo infantil, ex Jefe de Servicio de Neumonología infantil del Hospital del Tórax A. Cetrángolo.
 Miembro del comité de Neumonología infantil de la SAP.

**Dr. Luciano Alva Grimaldi

Neumólogo infantil. Instructor de residentes de Clínica pediátrica del HLM, Miembro titular de la SAP.
 Docente de pediatría UBA, sede HLM.

MANEJO INTEGRAL DEL ASMA INFANTIL



Dr. Néstor Pisapia*

Sumario

El asma bronquial es la enfermedad crónica más prevalente de la infancia y la adolescencia siendo un problema de salud muy importante en nuestra sociedad debido a las limitaciones que la enfermedad provoca al niño y a su familia en sus actividades cotidianas, incluido el ausentismo escolar, el ausentismo laboral que genera en los padres y además los costos económicos en gastos de medicamentos y servicios de salud. La asistencia centrada en el paciente ha demostrado ser más eficaz que la atención centrada en la enfermedad.

Introducción

Podemos definir que el asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas. Como respuesta de esta inflamación crónica, las vías aéreas desarrollan un evento conocido como hiperreactividad; caracterizado por obstrucción en el flujo de aire cuando se ponen en contacto con una serie de factores de riesgo (broncoconstricción, tapones de moco y aumento de la inflamación). Entre los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de asma se incluyen la exposición a alérgenos (ácaros en el polvo casero, animales, cucarachas, pólenes y moho), irritantes ocupacionales, humo de cigarrillo, infecciones respiratorias virales, ejercicio, estados de ánimo, irritantes químicos y medicamentos (tales como aspirina y beta-bloqueantes) (3-4).

El proceso inflamatorio en el asma lleva a fenómenos de destrucción y reconstrucción alternativos del epitelio (remodeling). Pero el epitelio reparado no es similar al original, lo que conduce a remodelación anómala de la

mucosa bronquial con desarrollo de lesiones permanentes que originan una obstrucción del bronquio progresiva e irreversible lo que ensombrece el pronóstico de la enfermedad (5). De ahí que el diagnóstico precoz sea un elemento importante para el control y tratamiento de la enfermedad que nos va a permitir realizar prevención secundaria e impedir que la enfermedad progrese y origine secuelas (6). Hasta hace poco el manejo integral del asma quedaba restringido al médico especialista, lo que limitaba el acceso de la población a un diagnóstico y tratamiento precoces de la enfermedad debido, probablemente al gran volumen de la demanda. Dado la gran prevalencia y la variedad de presentación del asma se hace necesaria una mayor participación del médico pediatra para el control y seguimiento del niño con asma.

El asma bronquial se puede diagnosticar a partir de la sintomatología y de la historia clínica del paciente (cuadro 1).

Las pruebas de función pulmonar nos proveen información adecuada sobre la severidad, reversibilidad y variabilidad de la limitación al flujo del aire. Nos ayudan a confirmar el diagnóstico del asma en pacientes mayores de 5 años (7).

La Espirometría es el método de preferencia para medir la limitación al flujo de aire y su reversibilidad para establecer el diagnóstico del asma. Un aumento de más $\geq 12\%$ en el FEV1 ($\geq 200\text{ml}$) luego de la administración de un broncodilatador indica reversibilidad a la limitación al flujo del aire, lo cual correlaciona con asma. Sin embargo, muchos de los pacientes asmáticos pueden no mostrar reversibilidad en cada valoración, por lo que se recomienda efectuarlas en

Considerar asma si alguno de los siguientes síntomas o signos están presentes:

- Episodios recurrentes de sibilancias, usualmente en más de una ocasión por mes
- Tos o sibilancias inducidas con el ejercicio
- Tos nocturna durante los períodos agudos sin virosis asociada
- Ausencia de sibilancias que varían con estaciones
- Síntomas que persisten después de los 3 años
- Síntomas que ocurren o empeoran con la presencia de:
 - Animales con pelos
 - Sustancias químicas en aerosol
 - Cambios de temperatura
 - Ácaros en el polvo doméstico
 - Medicamentos (aspirina, beta-bloqueadores)
 - Ejercicio
 - Polen
 - Infecciones respiratorias virales
 - Humo de cigarrillo
 - Estados emocionales muy marcados
- Síntomas que mejoran cuando se inicia tratamiento para el asma

Cuadro 1: Signos y síntomas.

varias ocasiones (8).

Cabe preguntarse si todos los niños que presentan sibilancias son asmáticos. La respuesta es NO, sin embargo la mayoría de los niños que presentan sibilancias luego de los cinco años es probable que tengan asma. El diagnóstico de asma en niños de 5 años o menores presenta un reto diagnóstico. La tos y la presencia de sibilancias episódicas son comunes en este grupo etario y no necesariamente son asmáticos, particularmente en aquellos menores a 3 años (9).

Entre menor sea la edad del paciente, más probable que exista otro diagnóstico alternativo para explicar los episodios de sibilancias recurrentes. Entre los hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo están: síntomas desde el nacimiento, sibilancias asociadas a la alimentación o a vómitos, comienzo brusco con tos o asfixia, esteatorrea, estridor, retraso de crecimiento, soplo cardíaco, hipocratismo digital, tórax rígido, signos pulmonares unilaterales, ausencia de reversibilidad con los broncodilatadores, hallazgos radiológicos pulmonares focales o persistentes.

El diagnóstico de asma en niños de 5 años o menores se basa mucho en la clínica, por lo que

es fundamental la historia clínica y los hallazgos al examen físico. Un método efectivo para confirmar el diagnóstico en este grupo etario es dar una prueba terapéutica con broncodilatadores de acción corta o glucocorticoesteroides inhalados (CEI).

Una mejoría notable con el tratamiento y deterioro a la hora de suspenderlo nos ayuda a apoyar el diagnóstico de asma.

Para realizar un adecuado tratamiento y control del asma lo primero es reconocer la enfermedad. Para conseguir que el niño y su familia acepten la enfermedad hay que comenzar a llamarla por su nombre “su hijo tiene asma”. Es imprescindible que la familia identifique el asma como una enfermedad crónica susceptible de un buen control.

Debemos tener en cuenta algunas recomendaciones para lograr un manejo exitoso del tratamiento:

Respecto a los inhaladores: El paciente será entrenado en la utilización del dispositivo y nunca se recetará un inhalador sin comprobar antes, que el niño realiza la técnica correctamente. Se debe comprobar en cada visita la técnica de inhalación, seleccionando para cada niño el dispo-

Elección del inhalador para niños con asma

Edad	Dispositivo preferido	Dispositivo alternativo
Menor de 4 años	Aerosol + espaciador con máscara facial	Nebulizador con máscara facial
4-6 años	Aerosol + espaciador con pieza bucal	Nebulizador con pieza bucal
mayor de 6 años	Polvo seco o aerosol + espaciador con pieza bucal	Nebulizador con pieza bucal

BASADO EN LA EFICACIA DE ENTREGA DE DROGA, COSTOS, SEGURIDAD, FACILIDAD EN EL USO Y CONVENIENCIA

Cuadro 2: elección inhalador según edad

sitivo más adecuado. Se recomienda utilizar los aerosoles con aero-cámaras con válvula, máscara facial o piezas bucales, según la edad. (cuadro 2)

SE CAMBIARÍA LA PALABRA ESPACIADOR POR AERO-CÁMARA, YA QUE ASUMIMOS QUE ESTAS ÚLTIMAS TIENEN VÁLVULAS, Y LOS ESPACIADORES NO

Evitación de desencadenantes: Reconocerlos y saber cómo prevenirlos. Recomendar ambiente libre de humo.

Tratamiento farmacológico

Estimular a la utilización precoz de la medicación de rescate. Diferenciar el tratamiento de rescate del tratamiento crónico o controlador. Buscar la adherencia escuchando las dificultades y rechazos al tratamiento por parte del paciente y/o la familia. No aumentar nunca las dosis de fármacos sin comprobar la técnica de inhalación y la adherencia real al tratamiento.

Plandeacción: Se debe explicar verbalmente, valorar su comprensión y siempre entregar por escrito. *Calidad de vida:* evaluar la calidad de vida del paciente y su familia (11). Evitar la sobreprotección y recomendar la asistencia al colegio y práctica habitual de ejercicio físico. En cuanto al tratamiento basado en el control de la enfermedad, cada paciente es asignado a uno de los escalones del tratamiento.

En cada uno de los pasos, el tratamiento de rescate debe de ser utilizado para el alivio de los síntomas según sea necesario. Sin embargo, es importante tener en cuenta la frecuencia con la que se utiliza éste tratamiento de rescate, ya que si se lo hace de manera regular o su utilización ha ido aumentando se considera un paciente no controlado.

De los pasos 2 al 5 el paciente va a requerir de la utilización de uno o más medicamentos controladores, los cuales evitan la presencia de sintomatología o crisis de asma. Los glucocorticoesteroides inhalados (CEI) son los medicamentos controladores más utilizados actualmente disponibles. Para los pacientes recién diagnosticados con asma o aquellos que no recibían tratamiento deben de ser ubicados en el paso 2 (si el paciente está muy sintomático en el paso 3). Si el asma no se logra controlar en el paso en que se encuentra el paciente, se progresa hasta lograr ubicarse en un paso donde se mantenga un adecuado control.

El medicamento controlador más recomendable a iniciar en un niño de 5 años o menor son los CEI como terapia inicial. Si este tratamiento no logra controlar los síntomas, la mejor opción es aumentar la dosis del mismo, mientras que en los mayores de 5 años ante la falta de control con CEI la opción preferencial es la utilización de la terapia combinada.

Existen una gran variedad de medicamentos

controladores y de rescate disponibles en el mercado. El tratamiento a utilizar por determinado individuo depende de los recursos locales y de las circunstancias individuales de cada persona (12).

Para concluir podemos decir que el asma es una enfermedad crónica, compleja y variable cuyo manejo no se debe basar solo en el tratamiento farmacológico, sino en la educación, ya que es una parte fundamental del proceso de intervención, siendo un elemento clave para mejorar los resultados expresados en términos de:

Mejorar el reconocimiento de los síntomas por parte del niño y de sus cuidadores

Disminuir el número de ingresos hospitalarios así como las consultas a los servicios de urgencias generando menores costos de salud.

Reducir el ausentismo escolar del niño y laboral de los padres.

Referencias bibliográficas

1. Gómez, M. Epidemiología del asma en Argentina. *Archivos de Alergia e Inmunología Clínica* 2006; 37(2): 63-70.
2. Lezama V., Aranebia C. Consideraciones epidemiológicas del asma en Latinoamérica. *Revista de Neumonología Pediátrica*, 2006, vol 1 n°2 pag 45-48.
3. Yeatts K, Sleath B, Ayala GX, Gillette C, Williams D, Davis S, Tudor G. Communication and education about triggers and environmental control strategies during pediatric asthma visits. *Washington D. Patient Educ Couns*. 2011 May 18.
4. Gallagher J, Hudgens E, Williams A, Inmon J, Rhoney S, Andrews G, Reif D, Heidenfelder B, Neas L, Williams R, Johnson M, Ozkaynak H, Edwards S, Cohen Hubal E Mechanistic Indicators of Childhood Asthma (MICA) Study: piloting an integrative design for evaluating environmental health. *BMC Public Health*. 2011 May 19;11(1):344.
5. Busse W, Elias J, Sheppard D et al. Airway Remodeling and Repair. *Am J Respir Crit Care Med* 1999;160:1035-1042.
6. Ulrik CS. Outcome of asthma: longitudinal changes in lung function. *Eur Respir J* 1999; 13: 904-918.
7. Consenso de Asma Bronquial. *Arch. argent. pediátr*. v.106 n.2 Buenos Aires mar./abr. 2008.
8. Pérez-Yarza, J Villa, N Cobos, M Navarro, A Salcedo, C Martín, A Escribano, L Arranz, S Rueda, A Martínez. Espirometría forzada en preescolares sanos bajo las recomendaciones de la ATS/ERS: estudio CANDELA. *Anales de Pediatría*, Volume 70, Issue 1, Pages 3-11
9. Castro-Rodríguez JA ¿Cómo evaluar el riesgo de asma bronquial en lactantes y preescolares? *Arch Bronconeumol*. 2006;42:453-6.
10. Castro-Rodríguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Martínez FD, et al. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. *Am J Respir Crit Care Med* 2000;162(4pt1):1403-6.
11. Juniper EF. Health-Related Quality of Life. En: Barnes PJ et als, Eds *Asthma*. 1997. p. 1487-1497.
12. The Global Initiative for Asthma (GINA 2009) National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, USA, and the World Health Organization.

*Dr. Néstor Pisapia

Médico de Planta en Pediatría. Servicio de Neumonología pediátrica, Hospital Italiano de Buenos Aires.

Neumonólogo Pediatra. HIGA Vte. López y Planes de Gral. Rodríguez

SubDirector de la Carrera de Médico Especialista en Neumonología Pediátrica UBA. Instructor de Residentes de Clínica Pediátrica del HIGA Vte. López y Planes.

TUBERCULOSIS PULMONAR PRIMARIA GRAVE.

NIÑO DE 4 AÑOS CON SÍNDROME FEBRIL Y TOS PERSISTENTE

Hospital Municipal de Morón



Dra. Paula Inés Villalba

Dra. Mariana Rotolo

Dra. Natalia Cuevas

Residencia de Clínica Pediátrica

Dra. Isabel Squazzi*

Revisora

Sumario

La tuberculosis sigue vigente en nuestro medio. Debe ser aun hoy un planteo diagnóstico ante pacientes con evolución clínica tórpida y sin respuesta al tratamiento habitual. Si el paciente presenta criterios compatibles con tuberculosis no debe demorarse la iniciación del tratamiento específico. Sospecharla ante un cuadro clínico compatible, con imágenes compatibles con tuberculosis, PPD positiva, contacto sospechoso o confirmado

Situación clínica

Nicolás es un niño 4 años de edad que comienza un mes antes a la internación con síndrome febril y tos catarral.

Debido a este cuadro clínico concurre a su pediatra de cabecera quien le solicita una radiografía de tórax, donde se observa una imagen compatible con neumonía de lóbulo superior

derecho. Le indica tratamiento con penicilina por 10 días.

Luego de este tiempo mejora la curva térmica pero la paciente persiste con tos a predominio nocturno, por lo que consulta nuevamente en nuestro hospital.

Es imprescindible, realizar un nuevo y minucioso interrogatorio y examen físico.

Realizada una anamnesis adecuada, se constata que nuestro paciente fue un recién nacido de término, con peso adecuado a edad gestacional y presentó una bronquiolitis leve a los 5 meses.

Las vacunas se encuentran completas.

Es el cuarto 4 hijo, de una familia en vulnerabilidad social, que convive con 7 adultos en la misma casa., uno de ellos, su tío está internado actualmente por "EPOC".

Nicolás se encuentra en regular estado general, impresiona adelgazado, con palidez cutáneo-mucosa.

A la auscultación no presenta dificultad ven-

tilatoria, se auscultan rales gruesos en ambos campos. Resto de examen físico sin hallazgos de relevancia.

Se solicita una radiografía de control:



1. Radiografía de Tórax.

Reflexión

Teniendo en cuenta el cuadro clínico del paciente, y los hallazgos en la radiografía, se decide su internación.

Se le solicita PPD con resultado 5 mm.

Se reinterpreta el cuadro como sospecha de Tuberculosis Pulmonar, se realiza interconsulta con infectología, indicándose terapia antibiótica combinada cubriendo neumonía a gérmenes comunes y tuberculosis pulmonar desde su ingreso.

Se tomaron muestras de esputos en tres periodos durante la internación, al ingreso, 15 días y 30 días de tratamiento, con resultados BAAR XXX, X y negativo, respectivamente. Hemocultivos negativos.

Debido a las drogas antituberculosas intercurrió con hepatitis medicamentosa, la cual requirió seguimiento estricto con laboratorio y asesoramiento del servicio de hepatología de un hospital de mayor complejidad, con buena evolución, no siendo necesario suspender la medicación.

Presenta una buena evolución del cuadro clínico, con registros febriles solo durante los primeros 10 días de tratamiento. No tuvo requerimientos de oxígeno durante la internación, a

la auscultación presentaba características de neumonía en vértice derecho y tos catarral que fue disminuyendo hasta su desaparición al momento del egreso.

Presenta mejoría de la anorexia y decaimiento generalizado.

Realiza seguimiento con servicio de psicología.

El servicio de neumonología local realiza catastro y profilaxis familiar.

Se realizan como exámenes complementarios: TAC de tórax, ecografía abdominal, radiografías de tórax y estudios de laboratorio semanales.

Al egreso se continúa el tratamiento con drogas antituberculosas y realiza seguimiento de la niña y familiar con servicio de neumonología local.

Este caso clínico nos deja como enseñanza la importancia de realizar un buen interrogatorio familiar, recabando antecedentes de patologías infecciosas familiares, la constancia de reinterrogar a la familia, para lograr una adecuada prevención y tratamiento de casos índices y profilaxis de convivientes.

Siempre que se investigue TBC se debe evaluar la radiografía de tórax, pues muchos pacientes pueden presentar lesiones radiológicas extensas con escasa o nula sintomatología clínica.

Comentarios

La TBC es una enfermedad infectocontagiosa producida por *Mycobacterium Tuberculosis*, bacilo ácido alcohol resistente de crecimiento lento. En los niños generalmente es resultado de una infección recientemente adquirida. Puede detectarse precozmente como infección o en su evolución a enfermedad activa.

Se estima que una tercera parte de la población mundial está infectada, de ese porcentaje 75 % vive en los países más pobres. Es considerada la séptima causa de muerte en el mundo y la primera originada por un solo agente infeccioso. Las cifras siguen en ascenso con 9 millones de casos nuevos y 3 millones de muertos por año.

En Argentina la tasa de incidencia anual es de 31/100.000 (12-14.000 casos por año), en el período 2010-2011, se registraron 777 casos de tuberculosis en niños menores de 4 años, 491 casos en niños de 5 a 9 años y 641 casos en niños de 10 a 14 años. 1

Se calcula que cada enfermo bacilífero llega a

infectar a 20 personas, dos de las cuales enfermarán (10%).

La puerta de entrada en más del 95 % de los casos es respiratoria. En los niños pequeños se observa la forma primaria de tuberculosis que se presenta a continuación de la primoinfección, como consecuencia del fracaso de los mecanismos inmunológicos para limitar reproducción del bacilo luego de su ingreso al organismo y la consecuente lesión tisular.

El diagnóstico de certeza se realiza mediante el aislamiento del bacilo. Sin embargo, las lesiones iniciales como las que presentan la mayoría de los niños, son paucibacilares. Por lo tanto, el diagnóstico en pediatría se debe realizar basándose en elementos epidemiológicos, clínicos y radiológicos.

Los enfermos bacilíferos, con esputos positivos, son los de mayor infectividad ya que pueden infectar al 50 % de los convivientes y al 8 % de los contactos extrafamiliares.

La búsqueda de enfermos o infectados expuestos a un enfermo bacilífero se denomina estudio de contacto o control de foco. Esto consiste en estudiar a todos los contactos con pruebas tuberculínicas, radiografía de tórax y baciloscopía de esputo si son sintomáticos respiratorios por 15 días o más.

Luego del contagio, durante varias semanas, el *Mycobacterium Tuberculosis* crece lentamente y sin impedimentos en los macrófagos aún inactivos. Habitualmente hay un foco único localizado en los segmentos medios e inferiores del pulmón y puede diseminarse a los vértices y a otras partes del organismo.

Es el período de incubación biológica que transcurre desde el contagio hasta que sobreviene la reacción inmunológica específica. Una vez alcanzada la carga bacilar suficiente aparece la reacción inflamatoria y se desencadena la inmunidad celular que frena el crecimiento bacteriano. Los linfocitos CD4 son los principales mediadores de la inmunidad y actúan activando macrófagos. Los macrófagos y linfocitos T activados encierran a los bacilos en granulomas o tubérculos característicos denominados “fóliculos de Koester”, con necrosis (caseificación) central formando en su agrupación el “foco primario de Kuss y Ghon” en el parénquima pulmonar. Con el pasaje a los ganglios linfáticos locales conforman el “complejo de Ranke”. Cuando la población de linfocitos activados alcanza cierto

número se puede diagnosticar primoinfección por el viraje en la PT cutánea con antígenos bacilares (PPD).

En la mayoría de los casos la primoinfección es controlada por la inmunidad mediada por células. Estos individuos no tienen la capacidad de transmitir la enfermedad ya que el bacilo está latente. Este período se denomina período de incubación clínica.

Cuando la respuesta del huésped frente a la infección resulta inadecuada sobreviene la enfermedad, la cual se manifiesta por la presencia de síntomas y signos clínicos que sólo puede confirmarse por el aislamiento del *Mycobacterium Tuberculosis*.

Los bacilos pueden diseminarse a partir del foco primario por vecindad a pleura o bronquios y por vía linfática o hemática a otros órganos, habitualmente con altas tensiones de oxígeno como ápices pulmonares, riñones y zonas de crecimiento óseo.

El riesgo de enfermar no es el mismo en todos los infectados; el mayor riesgo corresponde a los niños recién infectados, de tal manera que a menos tiempo transcurrido desde la infección, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Formas clínicas de presentación

Si bien la mayoría de los casos se presentan en el pulmón, existen otras localizaciones, por lo que se clasifica:

Tuberculosis pulmonar: Es la más frecuente y la más contagiosa de las formas de tuberculosis, representa alrededor del 80 al 85% del total de los casos.

La presencia de alguno de los siguientes síntomas, debe hacer sospechar que una persona puede tener TBC pulmonar:

- Tos y expectoración por más de 15 días (la casi totalidad de los enfermos pulmonares bacilíferos presentan estos síntomas).
- Expectoración con sangre (hemoptisis), con o sin dolor torácico y dificultad para respirar.
- Síntomas generales como pérdida de peso o de apetito, fiebre, sudoración nocturna, cansancio, decaimiento.

Tuberculosis extrapulmonar: Se calcula que las localizaciones extrapulmonares constituyen entre el 15% y el 20% de todas formas de TBC,

aunque en la asociación TBC/Sida la proporción es mayor.

Las formas extrapulmonares más frecuentes en nuestro país son las pleurales, ganglionares y, en menor medida, genitourinarias, osteoarticulares y gastrointestinales.

La pleuresía tuberculosa es la única patología extrapulmonar considerada una forma moderada o común de tuberculosis.

Los síntomas generales de la TBC extrapulmonar son similares a los de la pulmonar: fiebre, astenia, decaimiento, sudoración nocturna, pérdida de peso, disminución del apetito entre otros. A estos síntomas y signos se agregan los específicos para cada localización.

Otras clasificaciones utilizadas son:

- ✓ Infectado (no enfermo): también llamada primoinfección tuberculosa, presenta PPD positiva o viraje tuberculínico o nódulo precoz (aparición del nódulo antes de cumplirse las dos semanas de la vacunación con BCG en un niño no vacunado previamente). No presenta anormalidades clínicas ni radiológicas. En el 90-95% de los casos la curación se produce en forma espontánea. Como su riesgo de enfermar está aumentado, corresponde instituir quimioprofilaxis secundaria.
- ✓ TBC primaria oculta: PPD positiva, asintomático, radiografía de tórax con imágenes del complejo primario bipolar o decapitado (forma ganglionar mediastinal). Puede observarse eritrosedimentación ligeramente aumentada, pero los demás exámenes complementarios son normales.
- ✓ TBC primaria manifiesta: PPD positiva, radiografía de tórax patológica, con síntomas clínicos y alteraciones humorales compatibles con TBC.
- ✓ TBC primara grave: Son formas progresivas y extensas, bronconeumónicas o cavitadas (formas tisiógenas), formas diseminadas hematógenas (miliar) o con compromiso extrapulmonar (TBC osteoarticular (Pott), meníngea, ganglionar periférica, etc.). La PPD puede ser positiva o negativa.
- ✓ TBC Extraprimaria o secundaria: Se presenta en niños mayores y adolescentes, con lesiones radiológicas similares a la TBC del adulto. Suelen presentar baciloscopías

positivas, tos, astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis.

- ✓ TBC Neonatal: Según el momento de contagio es: Congénita o perinatal, adquirida intraútero o en el canal del parto. La forma más frecuente de contagio es la postnatal que se adquiere de material infectado de la madre, otro conviviente o personal de salud.

Diagnóstico

El diagnóstico de tuberculosis en pediatría es un desafío, ya que la mayoría de los niños son paucibacilares (diagnóstico de certeza: aislamiento del bacilo) y con gran variación en los síntomas, desde asintomáticos a síntomas de enfermedad generalizada. Debido a esta ecuación, se utiliza una conjunción de criterios, que favorecen el diagnóstico precoz y aumentan su probabilidad de certeza:

- Antecedente de exposición y contacto; antecedentes personales;
- Clínica compatible;
- Radiología compatible;
- Hiperergia tuberculínica;
- Aislamiento del bacilo en muestras del paciente;
- Una vez iniciado el tratamiento, respuesta positiva al mismo. Se considera evolución favorable temprana a la disminución de los síntomas clínicos dentro de las primeras 2 semanas.

Todo ello nos permite también definir el estadio en el que se encuentra el paciente y de esta forma poder iniciar medidas adecuadas de control, prevención y tratamiento.

1- Antecedente de exposición y contacto

La exposición del niño al contacto con un paciente con tuberculosis es el primer paso para el desarrollo de la enfermedad. Se debe buscar exhaustivamente este contacto, tanto en el ambiente intradomiciliario como entre las personas que frecuenten al niño especialmente en los últimos 2 años.

Si el contacto es un enfermo TBC conocido, se deberá averiguar desde cuando está enfermo, cuales son los medicamentos indicados, desde cuándo y con qué regularidad los recibe, y si

presenta enfermedad por micobacterias multi-resistentes.

Es de gran importancia ponerse en conocimiento si se ha iniciado el estudio de catastro.

2- Clínica compatible

Los pacientes infectados no enfermos, no presentan alteraciones clínicas (examen físico y laboratorio normal).

En los niños enfermos con tuberculosis las manifestaciones clínicas dependen de la carga bacilar presente y su virulencia, la edad, inmunocompetencia y susceptibilidad del huésped en el momento de la infección. La mayoría de los niños enfermos con tuberculosis pulmonar pueden hallarse asintomáticos o con pocos síntomas.

En general se observa disociación entre escasos signos físicos e importante magnitud lesional orgánica.

Suele describirse la presentación clínica según la edad, con las siguientes características:

- En recién nacidos: hipo o hipertermia, letargia o irritabilidad, succión débil, vómitos, diarrea, distensión abdominal, hipotonía y convulsiones.

- En lactantes y niños pequeños: mayor probabilidad de presentar síntomas generales (inapetencia, decaimiento, disminución o falta de progreso de peso, síndrome febril) o respiratorios (tos, sibilancias, neumonía unifocal o multifocal). En algunos casos los síntomas generales pueden estar asociados directamente con signos de localización extrapulmonar como adenitis periférica y meningoencefalitis. Estos niños con la suma de alguna comorbilidad (ej. Desnutrición e inmunodeficiencia) son los que tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad diseminada.

- En niños más grandes y adolescentes: Pueden ser desde oligosintomáticos hasta presentar formas primarias y extraprimaria de TBC, similar a la del adulto, con el clásico síndrome de impregnación bacilar, completo o incompleto (tos, astenia, anorexia, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre) con la semiología de bronconeumonía o cavitación pulmonar, en ocasiones acompañada de hemoptisis.

Laboratorio:

Es normal en los infectados, pero en los enfermos tampoco tiene mucha importancia en el diagnóstico. Puede presentar alteraciones inespecíficas como anemia hipocrómica, leu-

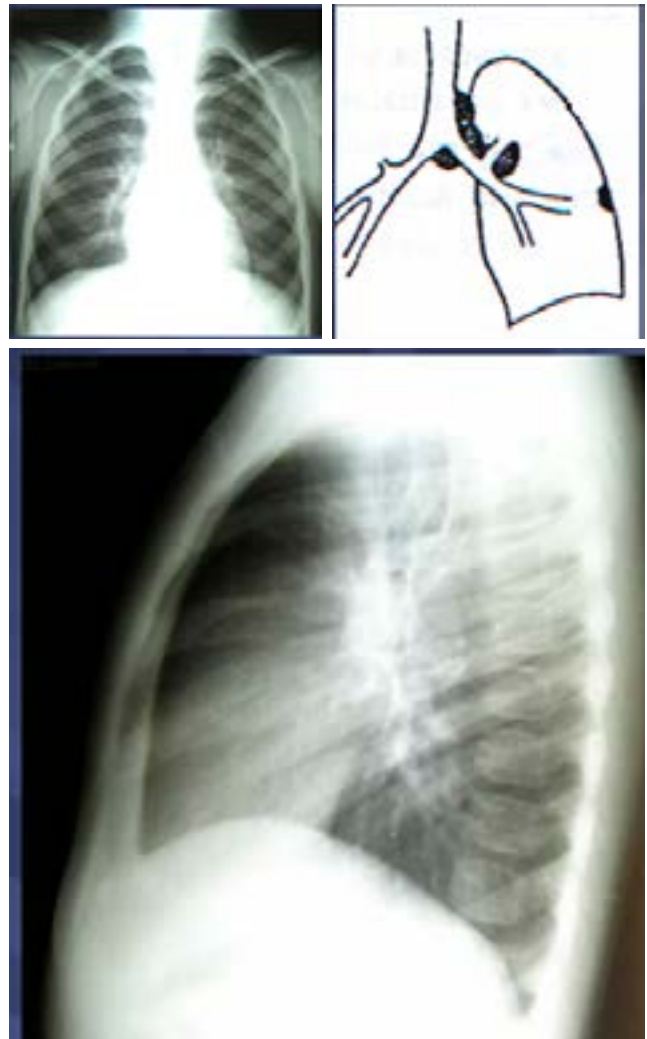


Figura 1 Complejo TBC primario



Figura 2 Nódulo Pulmonar

cocitosis, eritrosedimentación acelerada (cifras superiores a 80 mm se relacionan con intensa destrucción tisular: caseosis) y proteína C reactiva aumentada.

Debe solicitarse además del hemograma y los reactantes de fase aguda, el hepatograma y ácido úrico para el control de la medicación.

Otros estudios de laboratorio:

La enzima adenosindeaminasa-ADA, es una prueba que se basa en la función de la inmunidad celular, ya que aumenta en toda enfermedad que presenta activación linfocitaria. Su mejor eficacia es en líquido peritoneal, pleural y LCR. El punto de corte para considerarla positiva es de 47-50 U/l.

PCR, este método permite ampliar secuencias específicas del ADN del germen, puede ser aplicada a muestras de cualquier origen y requiere menos bacilos en la muestra que la baciloscopia. En adultos se han demostrado altos grados de especificidad y sensibilidad, pero en niños hay resultados muy variables por el alto número de falsos positivos y negativos. Por lo tanto una muestra positiva para PCR, como único método, no es suficiente para diagnosticar TBC.

3- Radiología compatible

La radiografía de tórax es uno de los pilares diagnósticos que debe incluirse en todo paciente con sospecha de tuberculosis pese a la manifestación clínica. Muchos pacientes presentan lesiones radiográficas extensas con escasa sintomatología clínica. Si es posible, se debería realizar el par radiográfico ya que el 25% de los infectados pueden presentar anomalías mínimas que pueden evidenciarse solo en la proyección lateral.

La característica principal y más frecuente de los pacientes con tuberculosis primaria es la hipertrofia de los ganglios hiliares y mediastínicos, esta reacción se produce de forma secundaria a la llegada del bacilo al sitio de inoculación en el parénquima pulmonar, pero que habitualmente no se evidencia radiológicamente. El complejo bipolar queda formado cuando se observa en la radiografía una opacidad periférica (sitio de inoculación) más opacidades mediastinales y/o hiliares, que se extienden en tractos lineales.

La mayor parte de las manifestaciones radiológicas, están relacionadas a la hipertrofia ganglionar y los trastornos de ventilación que producen por la obstrucción parcial o completa de las vías aéreas, como atelectasia o enfisema segmentario. En lactantes la atelectasia suele ser en el lóbulo superior derecho.

La diseminación, a partir del complejo primario, puede ser por contigüidad o linfohematogénea. Por contigüidad presenta las formas: perifo-



Figura 3. Agrandamiento ganglionar paratraqueal de la tuberculosis acompañada del agrandamiento de los ganglios hiliares



Figura 4. Progresión de lesión ganglionar: Obstrucción bronquial y atelectasia



Figura 5. Progresión de lesiones: derrame pleural

cal o hacia la pleura con derrame, broncogena, unifocal o polifocal confluyente. Por vía linfohematogena se observan las formas pulmonares extensas, con formación de granulomas en todo el lecho vascular pulmonar.

En las formas primarias la cavitación es rara, pero en el niño mayor y adolescentes, con reactivación, la enfermedad es similar a la de los adultos, con cavernas únicas o múltiples habitualmente en los vértices (7%).

La tomografía computada de tórax permite una mejor evaluación de las adenopatías mediastinales, patología endobronquial, bronquiectasias y compromiso pericárdico pero no agrega ninguna información en el niño con radiografía de tórax normal.

En las formas óseas las lesiones radiográficas son tardías y más destructivas que supurativas, con áreas quísticas de osteólisis con esclerosis marginal mínima.

4- Hiperergia tuberculínica

Es el procedimiento cuantitativo que consiste en la medición cuidadosa de las reacciones de la piel (reacción de hipersensibilidad retardada tipo IV cuantificable) a la inyección intradérmica de una dosis uniforme de tuberculina. Comúnmente es conocida como reacción de Mantoux.

Sólo evidencia el contacto previo del individuo con el bacilo siendo útil en caso de diagnóstico de infección tuberculosa en adultos, y como elemento auxiliar en el diagnóstico en lactantes y niños. También se utiliza para decidir la necesidad de quimioprofilaxis y determinar la prevalencia o incidencia de la infección tuberculosa en una población dada (esto no es aplicable en nuestro país dada la amplia cobertura con BCG).

Es de simple realización pero requiere entrenamiento previo. Se inyectan 0,1 ml de la dilución (2UT), en forma intradérmica, en la cara externa del antebrazo izquierdo en la unión del tercio superior y el medio, con el bisel de la aguja hacia arriba. Si la aplicación es correcta, se siente una resistencia al inyectar y aparece una pequeña pápula pálida de 6-10 mm, que desaparece en 10-30 minutos. En caso de sangrado o administración inapropiada puede efectuarse en el mismo momento otra aplicación a por lo menos 5 cm de distancia. La lectura debe realizarse a las



Figura 6. Progresión de lesiones: opacidades radiológicas segmentarias o lobares, generalmente de bordes mal definidos



Figura 7. TBC Miliar



Figura 8 TBC: cavitación

48-72 horas, midiendo la pápula, no el eritema, y se realiza en forma transversal al eje mayor del antebrazo. Se expresa en mm exactos.

Interpretación: En la población inmunocompetente, se considera positiva una reacción con una induración de 10 milímetros o mayor y en

los niños infectados con el VIH de 5 milímetros o más, pero se debe tener en cuenta que la prueba tuberculínica se relaciona con la infección por *Mycobacterium tuberculosis*, tanto reciente como previa. La reacción flictenular siempre es considerada positiva.

Una reacción negativa no descarta la infección tuberculosa y también pueden presentarse falsas reacciones positivas.

Falsos positivos

- Aplicación incorrecta (no es un falso positivo estricto, sino un error técnico).
- Error de lectura (ídem).
- Reacción cruzada a otras micobacterias.

Falsos negativos

- Almacenamiento y aplicación incorrectos.
- Error de lectura.
- Enfermedad tuberculosa diseminada (anergia tuberculínica).
- Coexistencia de enfermedades virales (sarampión, varicela, VIH).

Indicaciones de PPD:

Contactos recientes de enfermos bacilíferos o con sospecha de serlo.

Pacientes con riesgo aumentado de reactivación endógena (por comorbilidades)

Pacientes con clínica, radiología o exámenes de laboratorio compatible con TBC.

Grupos poblacionales con riesgo ambiental aumentado: por hacinamiento, cuidadores de la salud, etc.

5- Aislamiento del bacilo en muestras del paciente

El estudio bacteriológico tiene gran importancia epidemiológica y es la confirmación de la infección por *M. tuberculosis*.

La investigación se lleva a cabo por dos métodos: examen directo de la muestra, bacilosco-pía, que realiza una detección rápida pero con una sensibilidad baja y el cultivo, que tiene alta sensibilidad pero presenta mayor demora en los resultados.

Métodos de obtención de muestra para examen directo y cultivo de esputo:

Las muestras se deben tomar al aire libre o en una sala de toma de muestras con ventilación adecuada, en recipientes plásticos con tapa a rosca y boca ancha.

Los niños que pueden, expectoran, y los que

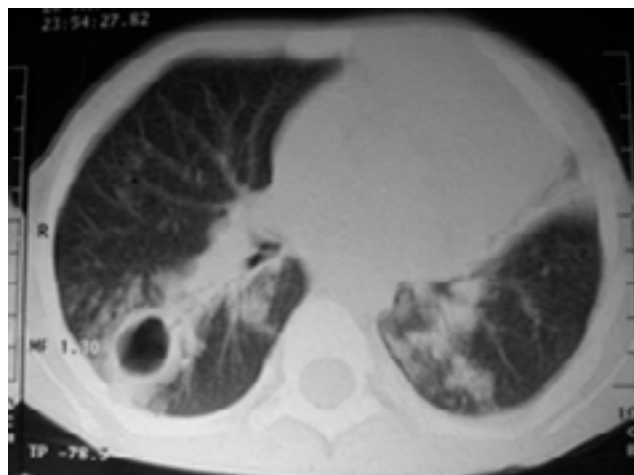


Figura 9 TAC cavitaria

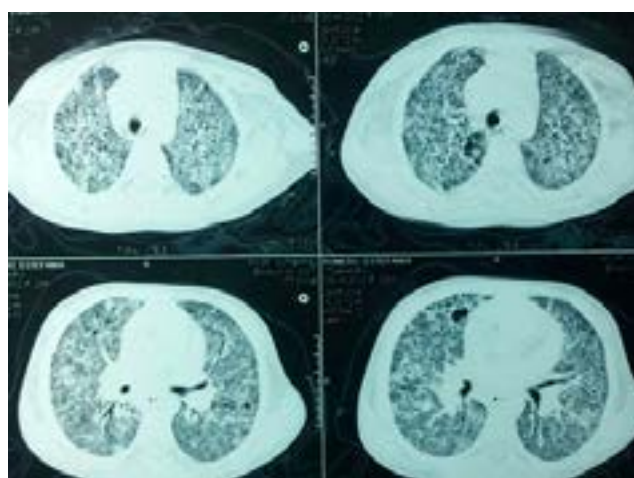


Figura 10 TAC miliar

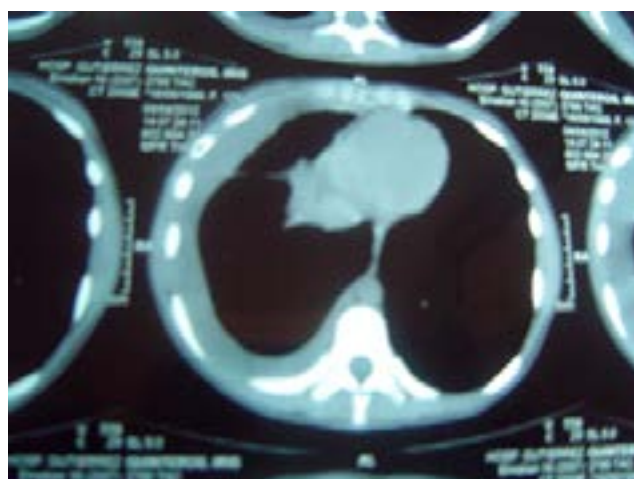


Figura 11 TAC pleural

no lo hacen se debe realizar el lavado gástrico. El mismo se realiza con el paciente en ayunas y reposo, al menos de 3 horas, al que se le coloca una sonda nasogástrica para aspirar el contenido gástrico, el cual se lava con 30-60 ml de

agua estéril y se envía para su inmediato procesamiento en un frasco estéril. Si la muestra se procesara con una demora de más de 6 horas, debe neutralizarse su PH ácido con bicarbonato de sodio.

Este procedimiento se realiza por tres días consecutivos, pudiendo obtenerse positividad del examen directo en los lavados gástricos oscila entre 0 y 20% de los niños con TBC pulmonar.

También se puede enviar muestras de: líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido de lavado bronquial o bronco alveolar, orina, biopsias ganglionares, etc.

En paciente inmunocomprometidos se deben tomar hemocultivos.

Examen directo, baciloscopía

La detección de BAAR es la primera evidencia bacteriológica de la presencia de micobacterias. Nos permite la estimación cuantitativa del número de bacilos eliminados.

El procedimiento se basa en la capacidad de las micobacterias de incorporar a su pared lipídica ciertos colorantes que no se eliminan con la decoloración ácido alcohol (BAAR). La más conocida es la técnica con Ziehl-Nielsen.

Es un método de detección por microscopia rápido, sencillo y de bajo costo., si bien tiene menor sensibilidad que el cultivo, ya que para obtener un resultado positivo requiere que la muestra presente, como mínimo, 5.000-10.000 bacilos/ml.

Para la información de los resultados se debe seguir un método estandarizado (OPS), informando las baciloscopias en cruces

No se encuentran BAAR en 100 campos observados (-)

Menos de 1 BAAR por campo, en promedio, en 100 campos observados (+)

Entre 1 a 10 BAAR, en promedio, en 50 campos (++)

Más de 10 BAAR, por campo, en 20 campos observados (+++)

La baciloscopía no determina la viabilidad del bacilo, pero es muy útil para el seguimiento de la respuesta favorable al tratamiento.

El resultado negativo no descarta la enfermedad tuberculosa. Como algunos pacientes eliminan bacilos de forma intermitente, se solicitan tres muestras en días sucesivos para aumentar el rendimiento.

Cultivos:

Es el método de elección para el diagnóstico e identificación del bacilo, ya que es la técnica de mayor sensibilidad en la detección de *M. tuberculosis* por requerir la presencia de sólo 10 bacilos/ml en la muestra para obtener un resultado positivo

El método de cultivo tradicional es el medio sólido Lowenstein-Jensen y Middlebrook, que pese a que tiene el inconveniente de la demora de la obtención de los resultados es el más utilizado y seguro. Para su desarrollo se requieren alrededor de 8 semanas.

Entre los métodos automatizados con medio líquido se encuentra el sistema BACTEC MGIT 960, que acorta significativamente el tiempo para la detección a menos de dos semanas. Su inconveniente es el costo de mantenimiento del aparato y los insumos, además de la necesidad de trabajar con material radioactivo.

Luego de la positivización del cultivo debe realizarse la identificación de la micobacteria. La prueba de susceptibilidad a fármacos necesita de otras tres semanas de incubación para determinar la resistencia, que se define como el crecimiento del 1% de la población bacilar en una concentración mínima de antibióticos.

Criterios de Internación

En la actualidad la mayoría de los pacientes se tratan ambulatoriamente, sin embargo hay situaciones en las que es necesario proceder a su internación:

- ✓ Formas graves pulmonares: con diseminación broncogénica (bronconeumonía), compromiso pleural (derrame, neumotórax), presencia de dificultad ventilatoria o hemoptisis, cavitaria o con diseminación hematogénica (miliar)
- ✓ Formas manifiestas con asociaciones morbosas (HIV, Inmunocomprometidos, desnutridos, diabéticos, etc)
- ✓ Menos de 12 meses con forma manifiesta
- ✓ Pacientes con baciloscopías positivas hasta su negativización.
- ✓ TBC extrapulmonar (osteoarticular, meníngea, renal, peritoneal, intestinal, cutánea, etc.)
- ✓ Mal medio socio-económico-cultural con dificultades para el estudio diagnóstico o tratamiento ambulatorio)

Se internará hasta completar el diagnóstico y asegurar supervisión terapéutica mediante de Tratamiento Directamente Observado (DOTS)

Tratamientos recomendados

El propósito del tratamiento de la TBC es esterilizar las lesiones tuberculosas lo más rápido posible. Los esquemas constan de una fase inicial (intensiva) de dos meses de duración y una fase de consolidación que suele ser variable y depende de la localización de la enfermedad.

Forma	1ra fase	2da fase	Total
Moderada	2 HRZ	4 HR	6 meses
Grave	2 HRZE o 2 HRZS	4 HR	6 meses
Miliar, meníngea, osteoarticular o HIV/SIDA	2 HRZE o 2 HRZS	7-10 HR diaria	9-12 meses

H: Isoniacida, R: Rifampicina, Z: Piracinamida, E: Etambutol, S: Estreptomina

Figura 12. Tratamiento de la tuberculosis.

Los fármacos de primera línea para el tratamiento son:

Fármaco	Dosis (mg/Kg/día) régimen diario	Dosis (mg/kg/día) bisemanal	Actividad	Efectos adversos
Isoniacida	5-10 (máx 300 mg)	15-20 (máx 900 mg)	Bactericida intracelular y extracelular	Hepatotoxicidad, neuritis, hipersensibilidad, convulsiones
Rifampicina	10-20 (máx 600 mg) ingerir en ayunas	10-20	Bactericida intracelular y extracelular	Hepatotoxicidad, trombocitopenia, coloración anaranjada de orina y secreciones
Pirazinamida	25-30 (máx 2 gr)		Bactericida intracelular (esterilizante)	Hepatotoxicidad, hiperuricemia
Etambutol	15-20 (máx 2.5 gr). No recomendable en menores de 8 años		Bacteriostático intracelular y extracelular	Neuritis óptica reversible, disminución de la agudeza visual
Estreptomina	15 (máx 1 gr)		Bactericida extracelular	Ototoxicidad, nefrotoxicidad, erupción cutánea

Figura - Fármacos de 1º línea tratamiento tuberculosis

Los corticosteroides están indicados en los casos de enfermedad intrabronquial y adenomegalias hiliares que comprimen el árbol bronquial y producen dificultad respiratoria, en las formas miliares, en los derrames pleurales con desplazamiento del mediastino, en los derrames pericárdicos así como en las meningitis o tuberculomas cerebrales. Habitualmente se utiliza la prednisona a 1-2 mg/kg/día durante 4-8 semanas, con reducción gradual de la dosis. La pleuresía tuberculosa es la única patología extrapulmonar considerada una forma moderada o común de tuberculosis.

Medidas de Prevención y Control

La mejor medida es el diagnóstico temprano de la TBC activa, así como su tratamiento adecuado. La mejor estrategia se basa en el tratamiento acortado directamente observado (DOTS). Esta estrategia debe ser implementada por un miembro de la salud. Se ha demostrado que disminuye la transmisión y la mortalidad así como la emergencia de cepas multirresistentes y la ocurrencia de recaídas. Es fundamental la identificación de contactos de todo enfermo bacilífero.

Quimioprofilaxis

Tiene como principal objetivo prevenir la posibilidad de infección o de enfermar en la población en contacto con el paciente bacilífero.

Se deberá realizar control clínico al mes y PPD y RX tórax a los dos meses de iniciada la quimioprofilaxis. Si la PPD es positiva y la RX patológica se iniciará tratamiento.

Si la PPD es negativa y Rx normal, en niños mayores de 5 años, podrá suspenderse la Isoniacida luego de negativización del foco, de lo contrario se continuará con la profilaxis por 6 meses.

Monitoreo del tratamiento

La mejoría radiológica y clínica, con desaparición de los síntomas puede utilizarse como criterio para suspender el aislamiento, habitualmente al completar el primer mes de tratamiento.

La normalización de la radiografía en cambio, requiere varios meses y pueden permanecer aún lesiones cicatrizales y/o calcificaciones al fin del tratamiento. Por lo tanto si no se presentan complicaciones, los controles radiológicos pueden pautarse cada 2 o 3 meses, incluyendo las imágenes en los cambios de esquema y al finalizar el tratamiento. Es de vital importancia la información que se le suministra, oral y por escrito, a los responsables del paciente sobre los efectos del tratamiento: intolerancias, cambios de coloración de la orina, fotosensibilidad, toxidermias y cantidad de drogas en uso y duración de los esquemas.

Los controles clínicos, cada 15 a 20 días en la fase intensiva y mensualmente en la de consolidación, permiten evaluar evolución, signo sintomatología, progreso de peso, tolerancia a las drogas, ajuste de dosis y sensibilidad del caso índice y/o aparición de nuevos casos o abandonos de tratamiento.

La situación ideal es que todos los pacientes reciban tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES), si no fuera posible su implementación sistemática deben arbitrarse las medidas para lograrlo. Sin excepción deben recibir TAES: los pacientes adolescentes, los bacilíferos, los retratamientos, los multirresistentes o que requieren drogas subsidiarias y/o cuando se conoce la historia personal o familiar de abandonos previos, drogadicción, HIV o migraciones frecuentes o situación de calle. En estos grupos es mayor el riesgo de interrupciones en el tratamiento y para la comunidad.

Efectos adversos

Son poco frecuentes: Elevación asintomática de las transaminasas en 3-10%, hepatotoxicidad en 1%.

En los tratamientos combinados debería ser monitoreada la función hepática al inicio, a los 15 o 20 días y luego cada 2 meses si no se presentan alteraciones.

También se ha planteado no realizarlos salvo manifestación clínica y pautarlos para los pacientes desnutridos, los que reciben otros tratamientos o tienen daños funcionales previos, quienes pueden presentar toxicidad medicamentosa con mayor frecuencia.



Figura - Algoritmos quimioprofilaxis tuberculosis

Los controles hematológicos, endocrinos oftalmológicos, audiométricos y de función renal dependerán de las drogas en uso y las comorbilidades.

Todos los menores de 16 años deben recibir tratamiento en cualquier estadio: exposición, infección o enfermedad. No hay una sola droga que la cure, ni tampoco una única persona. El éxito terapéutico depende de la acción eficaz y conjunta del equipo de salud, el paciente y su familia. La notificación al Programa Nacional de Control es obligatoria.

Comentario de Experta

Dra. Isabel Squazzi

La primera consulta de Nicolás corresponde a un cuadro que impresiona de evolución aguda, con fiebre y tos productiva, y radiografía compatible con neumonía de campo medio derecho. Es medicado con penicilina.

En este caso, se hace evidente la necesidad de hacer un adecuado seguimiento de los pacientes, durante y después del tratamiento, en nuestro ejemplo, la evolución no fue la esperada. Si bien mejoró la curva febril, ésta no desapareció, por lo que en la segunda consulta hay que asumir el cuadro como un síndrome febril prolongado con foco respiratorio.

Ante esto, la tuberculosis es uno de los diagnósticos que hay que sospechar. Se debería interrogar al paciente para obtener otros datos clínicos, como ser apetito, actividad, pérdida de peso, sudor nocturno, dificultad respiratoria, características de la tos. Evaluar antecedentes personales, vacunas e interrogar sobre enfermedades agudas y crónicas en la familia.

En el examen físico es fundamental valorar el estado general, nutrición, presencia de adenopatías, hepato-esplenomegalia. Es necesario un examen respiratorio exhaustivo, incluyendo saturometría. Tanto el adelgazamiento como la palidez, los síntomas respiratorios persistentes y la saturometría normal que presenta Nicolás hacen pensar en una enfermedad crónica como tuberculosis.

Es imperioso repetir la radiografía, ya que si pensamos que es una neumonía bacteriana es necesario descartar complicaciones, y si sospechamos otros agentes infecciosos, puede ser orientativa.

La radiografía de Nicolás presenta un patrón

alveolar de consolidación en campo medio derecho. Además se evidencia el aumento hiliar bilateral compatible con la presencia de adenopatías a ese nivel e imágenes compatibles con calcificaciones a nivel del izquierdo. Estamos entonces ante una imagen persistente en pulmón.

Se debe solicitar al laboratorio un screenig de infección donde podemos encontrar reactantes de fase aguda elevados (VSG, PCR cuantitativa) y anemia normocítica normocrómica, a veces importante.

La reacción de PPD debe realizarse en busca de primo- infección tuberculosa sabiendo que un resultado negativo no descarta el diagnóstico. Nicolás tiene PPD 5mm la cual es considerada positiva dentro de su cuadro clínico.

Es necesario solicitar catastro familiar (PPD, Rx tórax y baciloscopia) en busca de un adulto contagiante (foco), haciendo hincapié en los síntomas respiratorios (aunque tengan otros diagnósticos de base).

Si consideramos que este paciente presenta clínica compatible, patrón radiológico sugestivo, PPD positiva y conviviente sintomático respiratorio, tenemos criterios suficientes para sospechar tuberculosis.

Debemos realizar una baciloscopia seriada de esputo intentando confirmar la enfermedad. En caso de que Nicolás no pueda expectorar, debe realizarse la toma de contenidos gástricos. En pediatría es necesario realizar siempre cultivo de todos los materiales obtenidos ya que habitualmente los niños son paucibacilares y el diagnóstico se confirma recién con el cultivo. Las lesiones que evidencia Nicolás en la radiografía corresponderían a lesiones abiertas, por lo que tenemos muchas probabilidades de confirmar la enfermedad, lo que se pone de manifiesto con los esputos +++.

El diagnóstico corresponde a tuberculosis pulmonar primaria, grave. Debe iniciar el tratamiento sin esperar los resultados de los cultivos. El mismo corresponde inicialmente a cuatro drogas de primera línea: isoniácida 10mg/k/día (máximo 300), Rifampicina 10mg/k/día (máximo 600), pirazinamida 25-30mg/k/día (máximo 2 gr) y etambutol 15-20mg/k/día, las cuales debe cumplir por 2 meses (fase inicial). Al final de esta primera fase se debe solicitar una nueva baciloscopia al paciente, la cual debe ser negativa. Nicolás respondió muy bien, presentado espu-

to negativo ya al mes. También debe solicitarle una Rx tórax y laboratorio para descartar efectos adversos. Posteriormente se inicia la segunda fase de tratamiento (fase de continuación) la cual requiere 2 drogas de primera línea: isoniacida y rifampicina, por un período de 4- 7 meses, según la evolución clínica y radiológica. Es fundamental poder realizar tratamiento supervisado (estrategia DOT), a todos los pacientes en tratamiento para asegurar el cumplimiento del tratamiento.

La hepatitis farmacológica (RAFA: reacción adversa a fármacos antituberculosos) es una de las complicaciones más frecuentes asociadas al tratamiento (5-10%). Según las normas nacionales se debe suspender el tratamiento en caso de que el paciente presente síntomas y laboratorio con transaminasas multiplicadas por 3 de su valor normal, o transaminasas por cinco aun en un paciente asintomático, en cualquier momento del tratamiento. Luego de normalizar el hepatograma, se deben reintroducir las drogas hepatotóxicas de a una, con control de laboratorio y clínico frecuente. Es importante tener en cuenta que nunca el paciente puede quedar medicado con una sola droga ya que induciríamos la aparición de cepas resistentes.

La respuesta clínica al tratamiento es lenta, objetivándose aumento de peso, disminución de los síntomas respiratorios y de la fiebre y normalización de los parámetros del laboratorio luego de 15 días o más. La imagen radiológica también evidencia una lenta mejoría, pudiendo ser normal recién al final del tratamiento o quedar con secuelas (fibrosis, cavidades).

Durante el seguimiento es fundamental el trabajo multidisciplinario junto a los Trabajadores Sociales, ya que son un pilar fundamental para el éxito del tratamiento.

Si bien los niños son paucibacilares, Nicolás, al tener esputo +++, es un foco contagiante, por lo que debe indicarse quimioprofilaxis a todos los contactos menores de 15 años con isoniacida luego de descartar en ellos la enfermedad activa.

Como resumen es importante tener en cuenta que la tuberculosis sigue vigente en nuestro medio. Debe ser aun hoy un planteo diagnóstico ante pacientes con evolución clínica tórpida y sin respuesta al tratamiento habitual. Si el paciente presenta criterios compatibles con tuberculosis no debe demorarse la iniciación del tratamiento específico.

Los criterios más importantes son:

- ✓ Cuadro clínico compatible, de evolución tórpida, con escasa o sin respuesta a tratamientos habituales.
- ✓ Radiología sospechosa, con imágenes compatibles con tuberculosis como cavitarias, miliares o bronconeumónicas, adenopatías mediastinales o hiliares.
- ✓ PPD positiva (su negatividad no descarta la enfermedad)
- ✓ La presencia de un contacto sospechoso o confirmado de TBC bacilífero.
- ✓ El estudio bacteriológico
- ✓ La respuesta acorde al tratamiento empírico.

Agradecemos la colaboración de la Dra. Squazzi, para la presentación del banco de imágenes de TBC*

Bibliografía

- Álvarez A. *Tuberculosis On line*. 2013 Hospital de niños Ricardo Gutiérrez. Centro respiratorio.
- Comité Nacional de Infectología SAP. *Libro azul de Infectología Pediátrica*. 4º Edición 2012; Cap 96
- Comité nacional de infectología y neumonología. *Tuberculosis infantil. Modificaciones a los criterios de Documento de consenso de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP); Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP)*.
- Comité Nacional de Neumonología y Comité Nacional de Infectología. *Tuberculosis Infantil. Modificaciones a los criterios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis infantil Arch Argent Pediatr* 2007;105:54-5
- Moreno-Pérez D, Andrés Martín A, Altet Gómez N, Baquero-Artigao F, Escribano Montaner A, Gómez-Pastrana Durán D, González Montero R, Mellado Peña MJ, Rodrigo-Gonzalo-de-Liria C, Ruiz Serrano MJ. *Diagnóstico de la tuberculosis en la edad pediátrica. An Pediatr (Barc)*. 2010; 73:143. Voyer, L. *Criterios de diagnóstico y tratamiento en pediatría. Hospital general de niños Pedro de Elizalde Segunda edición*. 2012.

Referencias

- 1- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Emilio Coni", Administración Nacional de Institutos de Salud (ANLIS), con base en la información oficial de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina 2012

*Dra. Isabel Squazzi

Médica Servicio Tisiología Hospital Ricardo Gutiérrez. Miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Miembro de la Comisión de infecciones en Pediatría de la Sociedad Argentina de Infectología.

EXPERIENCIA CON TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO (TAFO) EN 100 NIÑOS CON BRONQUIOLITIS EN UNA SALA DE INTERNACIÓN



Dra. Cristina Ciriaci*

Sumario

La terapia con alto flujo de oxígeno (TAFO) es beneficiosa para los lactantes con bronquiolitis evitando su ingreso a UCI y las posibles complicaciones de métodos más invasivos además de tener el beneficio de estar en compañía de sus madres, alimentándose a pecho en la gran mayoría de los casos.

Este método también tiene la ventaja de requerir una capacitación no compleja del personal médico y de enfermería.

Introducción

La terapia de alto flujo de oxígeno (TAFO) consiste en aportar a través de una cánula nasal un flujo de oxígeno (O₂) sólo o mezclado con aire por encima del flujo inspiratorio del niño.

El O₂ se humidifica (humedad relativa 95-100%) y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal (37°C).

Mecanismo de acción:

Lavado del espacio muerto nasofaríngeo: ya que este mecanismo contribuye a establecer mejores fracciones de gases alveolares el espacio muerto extratorácico es proporcionalmente de 2 a 3 veces mayor en niños que en adultos. Este mecanismo contribuye a establecer mejores fracciones de gases alveolares facilitando la oxigenación.

El gas calentado y humidificado:

- Disminuye la resistencia en la mucosa nasal inducida por el gas seco y frío
- Reduce el trabajo metabólico
- Necesario para calentar y humidificar el aire externo
- Produce un efecto beneficioso sobre el movimiento ciliar y el aclaramiento de secreciones
- Mejora la compliance y el volumen pulmonar
- Evita la respuesta broncoconstrictora que provoca el gas frío y seco

Pacientes y Métodos

Criterios de Inclusión:

Lactantes de 20 días a 24 meses de vida con diagnóstico de ingreso de Bronquiolitis (BQL) de moderada a grave según el score de Tal modificado

Criterios de Exclusión:

Inestabilidad hemodinámica

Depresión del sensorio

Deshidratación grave. Trastorno metabólico

Parámetros de Inicio:

Flujo de 2l/kg/minuto

FIO₂ de 0,6 a 0,9. La FIO₂ óptima es la que permita una oximetría de al menos 93-94%

Control Evolutivo:

Registro temporal de los siguientes parámetros: temperatura, oximetría de pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, evaluación del trabajo respiratorio y auscultación pulmonar. Los parámetros se recogieron al inicio, a los 30, 60, 90 y 120 m; 3, 6, 9, 12, 18 y 24 hs y luego cada 6 hs

Evaluar su estado clínico y la presencia de complicaciones

Criterios de fracaso de TAFO que requirieron una escalada de tratamiento:

Aumento de la FR y FC mayor al 20% del valor inicial

No mejoría a pesar de aumentar el flujo inicial

Deterioro del sensorio

Descompensación hemodinámica

Alimentación:

Una de las ventajas de TAFO es que luego de estabilizar al paciente se comienza con la alimentación siempre que sea posible con pecho a demanda y si esto no es posible por gavage o nutrición enteral continua

Parámetros para suspensión de TAFO:

Se comenzó reduciendo la FIO₂ el 20% del valor hasta una FIO₂ del 40% manteniendo el flujo

Luego se redujo el flujo de oxígeno 2l/minuto cada 2 hs con el objetivo de mantener una saturación de O₂ de 93-94%

Descripción de la experiencia realizada

- ✓ Se describe un trabajo descriptivo y retrospectivo de los pacientes ingresados desde abril a noviembre de 2019 con diagnóstico al ingreso de BQL
- ✓ Se incluyeron 100 pacientes que cumplían con el criterio de inclusión (68% de varones y 42% de mujeres)
- ✓ La edad media fue de 4 meses (de 20 días a 24 meses)
- ✓ En el 63% se detectó virus sincicial respiratorio (VSR) positivo y en el 5% adenovirus (ADV)
- ✓ La duración de TAFO tuvo una mediana de 3,6 días (1 a 7 días)
- ✓ No se observaron efectos adversos ni complicaciones por la técnica empleada
- ✓ Requirieron su pase a mayor complejidad

(Cuidados intensivos) 8 pacientes. De los cuales 4 requirieron ventilación no invasiva (VNI) y 4 requirieron asistencia respiratoria mecánica (ARM) 4 pacientes

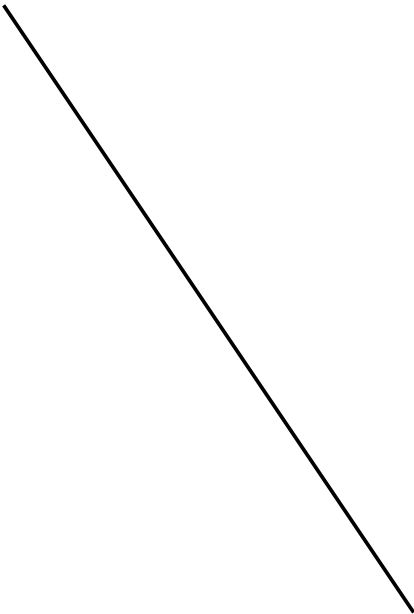
- ✓ Los pacientes que requirieron ARM fueron un lactante varón de 3 meses al que luego se hizo diagnóstico de hipogammaglobulinemia, una niña de 14 meses con bronquiolitis obliterante (BO) post ADV, una niña de 3 meses con ADV positivo que luego falleció y un niño de 1 mes con VSR positivo

Bibliografía

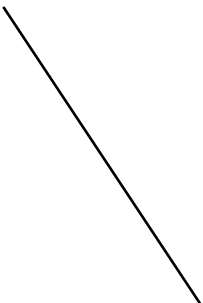
- Almasio A B, González Ros A y col. Oxigenoterapia de alto flujo. *Medicina infantil* 2019; XXVI:364-367
- Alonso B, Boulay m. Ventilación no invasiva en infección respiratoria aguda fuera del área de cuidado intensivo. *Rev.Chil.Pediatr* 2011; 82 (3) : 211-7
- Barbaro J y col. Oxigenoterapia por cánula nasal de alto flujo. Una revisión. *Rev Hosp.Niños (Bs As)* 2018; 60 (271):309-315
- Franklin D, Dalziel S et al. Early high flow nasal cannula therapy in bronchiolitis in prospective randomised control trial (protocol) *A Paedritic Acute Respiratory intervención study (PARIS)* *BMC Paediatr* 2015 Nov 14;15:18
- Franklin Donna, Franz Bet et al. A randomized Trial of high flow Oxygen Therapy in infants with bronchiolitis *N Engl J Med* 378; 12 March 22, 2018
- González Martínez, González Sánchez MI. Impacto clínico de la implantación de la ventilación por alto flujo de oxígeno en el tratamiento de la bronquiolitis en una planta de hospitalización pediátrica. *An Pediatr (barc)* 2013 Abr; 78(4): 210-5
- Lompland A, Plumm B et al. Observational study of humidified high flow nasal cannula-compared nasal continuous positive airway pressure. *J Pediatr* 2009;154:177-182
- Mayfield S, Jauncey-Cooke J et al High-flow nasalcannula therapy for respiratory support in children. *Cochrane database of Systematic Reviews* 2014. Issue 3
- Mc Kiernan Ch, Chadrick CL et al. High flow nasal cannulae therapy in bronchiolitis. *JPediatr* 2010;156:634-638
- Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Recomendaciones para la implementación de la terapia de alto flujo (TAFO) 2019
- Morosini F, Dall Orso P y col. Impacto de la implementación de oxigenoterapia de alto flujo en el manejo de la insuficiencia respiratoria por infecciones respiratorias agudas bajas en un departamento de emergencia pediátrica. *Arch Pediatr Urug* 2016;87(2) 87-94
- Tejera J, Pujadas M. Aplicación de oxigenoterapia de alto flujo en niños con bronquiolitis e insuficiencia respiratoria en piso de internación. *Arch Pediatr Urug* 2013; 84 (51) 528-533
- Torres S, Franco A. Terapias de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda en Pediatría. *SATI. Medicina Intensiva* 2013; 30 (4); 1-1
- Wegner A. Cánula nasal de alto flujo en pediatría. *Neum Pediatr* 2017

*Dra. Cristina Ciriaci

Jefa de Sala de Internación e Instructora de Residentes de Clínica Pediátrica del Hospital Materno-Infantil Te-tamanti de Mar del Plata



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **C**

DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE

Hospital Materno Infantil Tetamanti de Mar del Plata



Dra. Cristina Ciriaci*

Dra. Deysi Campos

Dra. Gabriela Capovilla

Dra. Antonella Colaneri

Dra. Gabriela Domijan

Dra. Melina Leppski

Dra. Natalia Pereyra

Dr. Leandro Rodríguez

Residentes de Clínica Pediátrica

Dra. Sandra Scarafoni**

Revisora

Sumario

El dolor abdominal es un síntoma frecuente en la consulta pediátrica. Representa un 2-4% de las visitas en atención primaria y un 50% de las consultas al Servicio de Gastroenterología, según la AAP. La mayor incidencia es en preescolares, entre los 5-7 años y preadolescentes.

Se debe diferenciar entre dolor abdominal crónico el cual es continuo, con duración de un mes, y dolor abdominal recurrente que se caracteriza por dolor de al menos 3 meses, con 3 o más episodios.

En el año 2016 según la actualización de los criterios Roma IV, no es necesaria la exclusión de todas las causas orgánicas para considerar el diagnóstico funcional.

NIÑA DE 5 AÑOS DE EDAD CON DOLOR ABDOMINAL DE 4 MESES DE EVOLUCIÓN

Situación clínica

Gabriela de 5 años de edad consulta por dolor abdominal de 4 meses de evolución. Fuera

del dolor realiza sus actividades diarias normalmente. Convive con sus padres y dos hermanos menores.

Anamnesis: El dolor abdominal es generalizado, a predominio periumbilical, de inicio súbito, se presenta alrededor de tres veces por semana y cede sin analgésicos. No se relaciona con cambios en hábito evacuatorio, ni se acompaña de náuseas, vómitos o pirosis. Madre refiere que la niña es previamente sana, con desarrollo y crecimiento acordes para su edad. No presenta antecedentes patológicos familiares. Hace 2 años nacieron sus dos hermanos.

Al reinterrogar a la madre cuenta que el dolor empeora durante las horas en que la niña se encuentra en el jardín o al cuidado de sus tíos.

Examen físico: Niña lúcida reactiva, eutrófica. FC 84 lpm. FR 20 rpm. TA 85/50 mmHg. Abdomen blando depresible e indoloro a la palpación. RHA positivos. No se palpan visceromegalias.

Estudios complementarios: Laboratorios de rutina y ecografía abdominal dentro de límites normales.

Clínica

Los trastornos digestivos funcionales están divididos por los criterios de Roma IV según la edad, en menores de 5 años -lactante y preescolar- y niños de 5 a 18 años.

Trastornos digestivos funcionales pediátricos: Lactante y niño pequeño. Roma IV

Requiritación del lactante
Síndrome de rumiación
Síndrome de vómitos cíclicos
Cólico del lactante
Diarrea funcional
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Trastornos digestivos funcionales pediátricos: Niño y adolescente. Roma IV

Trastornos de náuseas y vómitos funcionales	Síndrome de vómitos cíclicos Náuseas y vómitos funcionales Síndrome de rumiación Aerofagia
Trastornos del dolor abdominal funcional	Dispepsia funcional Síndrome de intestino irritable Migraña abdominal Dolor abdominal funcional no especificado de otra forma
Trastornos funcionales de la defecación	Estreñimiento funcional Incontinencia fecal no retentiva

Diagnóstico

Está basado en una anamnesis y examen físico completos. En estos cuadros es de suma importancia generar un vínculo sólido con el paciente y su familia, tanto durante la anamnesis detallada, como en el examen físico. Se debe escucharlos atentamente, guiarlos con preguntas relevantes, demostrarles que comprendemos su preocupación y explicarles con palabras sim-

ples cuál es nuestra impresión diagnóstica, las pautas de alarma a considerar, opciones de tratamiento y seguimiento con las que contamos. De esta manera se logra la confianza y tranquilidad de la familia sobre la benignidad de la patología desde el inicio.

Resulta importante reconocer los signos y síntomas de alarma para solicitar los exámenes complementarios necesarios y la derivación al especialista en Gastroenterología precozmente.

Los estudios complementarios deben ser dirigidos a la sospecha etiológica y ante duda diagnóstica se sugieren laboratorios basales: hemograma, eritrosedimentación, hepatograma, función renal, orina completa, coproparasitológico y serología para Enfermedad Celíaca. También podría considerarse la ecografía abdominal y en caso de alta sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, solicitar calprotectina en materia fecal.

En caso de encontrar resultados alterados en alguno de los exámenes anteriores sería oportuna la derivación al especialista con la sospecha diagnóstica adecuada.



Algoritmo Diagnóstico

Tratamiento

Dieta:

Actualmente se encuentran en controversia las recomendaciones acerca de los hábitos higiénico-dietéticos.

Todos los autores concluyen que es una de las medidas iniciales a tomar, tanto por la buena aceptación por parte del niño como su familia, así como también la falta de efectos adversos.

Al intentar discriminar cual es el cambio clave a realizar en esta medida, es donde se presenta el primer interrogante, ya que en la mayoría de los casos depende del síntoma cardinal del niño, por lo que debe adaptarse a esta situación y su familia.

A modo general algunas pautas indicadas son:

- ✓ Ingesta de líquidos entre 1,5-2 L/día
- ✓ Reducir ingesta de lactosa y fructosa (sustratos para la fermentación bacteriana que en caso de malabsorción puede asociarse a distensión abdominal, cólicos y diarrea osmótica. En particular la fructosa demostró beneficio luego de su reducción)
- ✓ Dieta equilibrada
- ✓ Ingesta de fibra (aumento gradual hasta 25-30 gr)
- ✓ Reducir ingesta de alimentos con TACC (se ha demostrado mejoría de síntomas en pacientes incluso con ausencia de enfermedad celíaca)
- ✓ Patrón regular de comidas

Por otro lado, resulta importante destacar dos aspectos más a tener en cuenta:

1- Cada niño responderá acorde a su síntoma principal (estreñimiento, diarrea, dolor, distensión) por lo que algunas de las medidas mencionadas mejoraran uno u otro. Cada una por separada a veces resulta inefectivo, y depende de la combinación de estas, junto a otras medidas tomadas por el profesional.

2- El ejercicio físico diario aeróbico favorece no solo el tránsito intestinal, sino que mejora estados de ansiedad y estrés, factores involucrados muchas veces en estos pacientes. Por lo que es otra medida a recomendar en niños con dolor abdominal recurrente.

Probióticos

La evidencia con respecto a la efectividad re-

BANDERAS ROJAS	
ANAMNESIS	EXAMEN FÍSICO
Dolor no periumbilical, que irradia a miembros o espalda	Pérdida de peso
Dolor persistente en cuadrantes superior e inferior derechos	Dolor a la palpación de cuadrantes superior e inferior derechos
Cambio en el ritmo o características de las deposiciones	Distensión o masa localizada
Sangre en las heces	Hepatomegalia o esplenomegalia
Náuseas y vómitos	Dolor a la presión en el ángulo costovertebral o en la columna vertebral
Disfagia	Anomalías perianales (úlceras o fisuras)
Artritis - Artralgias	Hematoquecia
Diarrea nocturna	
Dolor nocturno que despierta al niño	
Fiebre	
Síndrome miccional	
Pérdida de peso no voluntaria o detención de la talla	
Antecedentes familiares de EI, Celíaca o Úlcera péptica	
Anorexia	
Eritema nodoso	

lativa de diferentes cepas de probióticos es actualmente insuficiente para guiar la práctica clínica.

Se ha estudiado fundamentalmente en el cólico del lactante. Se han publicado ocho estudios que valoran el papel preventivo en los trastornos funcionales gastrointestinales del lactante, apreciando en sólo tres de ellos una disminución significativa al mes en el tiempo de llanto/día. El estudio que mayor muestra abarca, aprecia un efecto más amplio y prolongado ya que la ad-

ministración de 108 ufc/día durante 90 días se acompaña a los tres meses de una disminución en el tiempo de llanto/día, junto con una reducción en el número de regurgitaciones/ día, y un aumento en el número de deposiciones/día.

Lactobacillus reuteri DSM17938 es eficaz y se puede recomendar para lactantes amamantados con cólicos. Sin embargo, su papel en los lactantes alimentados con fórmula y cólicos aún necesita más investigación. Este producto aún no se encuentra para la venta en Argentina.

Psicoterapia

El abordaje psicoterapéutico del dolor abdominal dispone de un arsenal de técnicas que van desde la psicoterapia a la relajación, la hipnosis o los psicofármacos. Han demostrado ser efectivas en el tratamiento del DAR, ya que reducen los síntomas, disminuyen los episodios.

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es una opción eficaz de tratamiento en pacientes con dolor abdominal recurrente y síndrome de intestino irritable. Suele ser el tratamiento psicológico de elección. El objetivo es reconocer y cambiar actitudes, cogniciones y comportamientos que pueden desempeñar un papel en el origen y el mantenimiento de los síntomas.

Tratamiento Farmacológico

Procinéticos: se usan especialmente en pacientes con constipación y vaciamiento gástrico lento, como Sme. de intestino irritable (SII) y dispepsia funcional. La domperidona puede producir efectos adversos importantes, lo que limita su uso.

Antiespasmódicos: hiosciamina y dicitlomina tienen efecto anticolinérgico sobre el músculo liso, y puede usarse sólo por períodos cortos ya que tienen importantes efectos secundarios.

Antiácidos: bloqueadores H₂, inhibidores de la bomba de protones, son usados con mucha frecuencia, aunque su eficacia no ha sido documentada.

Antidepresivos: Actuarían reduciendo la percepción del dolor, mejorando el ánimo y los patrones de sueño y modulando el sistema gastrointestinal por efecto anticolinérgico. Serían de utilidad en pacientes con ansiedad y otras comorbilidades psiquiátricas. En el caso de los antidepresivos tricíclicos, que tienen efecto anticolinérgico ayudaría si la diarrea es un síntoma

importante, pero podría empeorar la constipación. La amitriptilina, por su efecto sedante, se indica en las noches, con dosis inicial de 0,2 mg/kg y aumento progresivo según síntomas hasta 0,5 mg/kg. Ya existen dos estudios clínicos que demuestran su eficacia en el tratamiento de SII y DAF. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) producen un aumento de la concentración presináptica de serotonina, que se traduce en mejoría del ánimo y disminución de la ansiedad, estando ésta implicada en la modulación de la motilidad colónica y dolor visceral intestinal.

Por otro lado, cabe destacar que los disparadores ambientales de dolor deben ser identificados y la fobia escolar debe ser considerada. Así como también estados de desadaptación, dinámica familiar alterada, niños o adolescentes víctimas, niños o adolescentes abusados, etc.

Opinión de expertos

En conclusión, el dolor abdominal funcional constituye un motivo de consulta muy frecuente tanto para el pediatra como para el especialista con una prevalencia del 13.5%. El avance en la terminología y la subclasificación de los criterios de Roma, ha alentado a los profesionales a realizar un diagnóstico positivo y ha aumentado la investigación en el área. Los mecanismos fisiopatológicos incluyen hipersensibilidad visceral, alteración de la motilidad gastrointestinal y cambios en la microbiota. Es posible que lo que factores ambientales y psicológicos interactúen con los factores genéticos afectando el eje cerebro intestino. El diagnóstico depende de la evaluación clínica mediante una anamnesis y examen físico completo con el fin de descartar causas orgánicas de dolor abdominal.

Las intervenciones terapéuticas no farmacológicas como cambios en la dieta y en el estilo de vida así como la explicación a los padres de la fisiopatología y comportamiento de estos trastornos funcionales ha mostrado eficacia a corto y largo plazo.

Hasta la actualidad no se cuenta con estudios de alta calidad científica que avalen el tratamiento farmacológico de los pacientes con dolor abdominal funcional. La investigación futura debe enfocarse en identificar los factores predictivos para optimizar y adecuar un tratamiento individual.

Bibliografía

- Abbott RA, Martin AE, Newlove-Delgado TV, et al. Recurrent abdominal pain in children: summary evidence from 3 systematic reviews of treatment effectiveness. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2018;67(1):23-33
- Álvarez-Calatayud, G., Pérez-Moreno, J., Tolín, M., & Sánchez, C. Dolor abdominal funcional: (2013). *Aplicaciones clínicas del empleo de probióticos en pediatría. Nutrición hospitalaria*, 28(3), 564-574.
- Berbel Tornero O, Clemente Yago, García Rodríguez, Pereda Pérez. Dolor abdominal crónico y recurrente. *Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Asociación Española de Pediatría.*
- Brusaferro, Edoardo Farinelli, Letizia Zenzeri, Rita Cozzali, and Susanna Esposito. *The Management of Paediatric Functional Abdominal Pain Disorders: Latest Evidence Recurrent Abdominal Pain in Childhood.*
- González, Francisca Corona. *REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(2) 177-183]*
- Mearin, a C. Ciriza, b M. Mínguez, c E. Rey, d J.J. Mascort, E. Peña, f P. Cañones. *Guía de práctica clínica del síndrome del intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento funcional en adultos: tratamiento. (Parte 2 de 2) F. J. Júdez, h and en nombre de la SEPD, la semFYC, la SEMERGEN y la SEMG.*
- Rodríguez G., Rossana Faúndez H., Daniela Maure O. *Rev Chil Pediatr* 2012; 83 (3): 279-289

*Dra Cristina Ciriaci

Médica Consultora en Pediatría.

Jefa de Sala de Internación del Hospital Tetamanti de Mar del Plata

Instructora de Residentes de Clínica Pediátrica

**Dra. Sandra Scarafoni. Revisora

Servicio de Gastroenterología

HEMORRAGIA DIGESTIVA EN PEDIATRÍA

Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela.
Residencia de Pediatría



Dr. Lucas Ruíz*

Dra. Justina Salvatierra González

Residente

Dra. Viviana Bernedo**

Revisora

Sumario

En este artículo podemos ver claramente las causas, el seguimiento y el tratamiento de la hemorragia digestiva que un pediatra debe saber. Nos brinda herramientas básicas para hacer diagnóstico y enfrentarnos a realizar un esquema de tratamiento según el tipo y gravedad de la Hemorragia.

Esta es una información que debe manejar el pediatra o médico generalista que reciba a un paciente pediátrico con Hemorragia digestiva en el Centro de Salud en el que trabaja, ya que por el tipo de presentación y la repercusión que tiene el sangrado de un niño en sus cuidadores son pacientes que ingresan por guardia de cualquier Hospital. Se debe tener en cuenta lo importante que es la estrategia de tratamiento en las primeras horas de sangrado, sobre todo en la hemorragia digestiva alta, ya que las conductas de tratamiento que se tomen en estos pacientes repercutirán en su buena evolución.

Caso Clínico

Paciente femenina de 5 años cursando cuadro con tos seca y fiebre de pocas horas de evolución. Se auto médica con dosis única de corticoides vía oral (VO) e ibuprofeno. Evolucionando

favorablemente sin volver a repetir registros febriles y sin tos.

Luego de 4 días consulta a la guardia por presentar vómitos porráceos y odinofagia, es diagnosticada como amigdalitis y comienza con amoxicilina VO, es enviada a su domicilio para cumplir tratamiento.

Persiste con vómitos sanguinolentos y dolor abdominal epigástrico por lo que recurren a la guardia nuevamente, se decide internar por sospecha de hemorragia digestiva.

Paciente estable hemodinámicamente donde arroja los siguientes datos de laboratorio: Glóbulos blancos: 5070 /ml (Neutrófilos 68% Linfocitos 19 %) hemoglobina: 14 gr%, Hematocrito: 42%, Plaquetas: 380000/ml. Coagulograma, radiografía de tórax y abdomen se informan como normales, se indica ayuno e inhibidores de bomba de protones (IBP) a 2 mg / kg EV.

Se deriva a otro centro hospitalario para realizar videoendoscopia alta (VEDA).

Videoendoscopia

Esófago: Mucosa de aspecto normal.

Estomago: En región pre pilórica se observa úlcera forrest 2A; se realiza esclerosis química con adrenalina. Imagen 1 y 2

Duodeno: Mucosa de aspecto normal.



Imagen 1



Imagen 2

A las 72 hs se realiza VEDA control donde se informa:

Esófago: Mucosa de aspecto normal

Estomago: Mucosa de cuerpo y techo normal. A nivel pre pilórico, se observa úlcera circunferencial recubierta con fibrina, sin signos de sangrado activo. Se toman muestras para biopsias. Imagen 3 y 4

Duodeno: Mucosa de aspecto normal.



Imagen 3



Imagen 4

El paciente evoluciona favorablemente y continua con tratamiento con IBP a 2 mg / kg.

Conceptos y manejo de la hemorragia digestiva

Hemorragia digestiva (HD) es la pérdida de sangre manifiesta u oculta que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, primario o secundario a una enfermedad sistémica.

Etiología

En el primer contacto con el paciente para comenzar a orientar hacia la posible etiología es importante la valoración de hemorragias digestivas verdaderas o falsas, descartando diferentes situaciones ya sea por alimentos, fármacos o sangrados provenientes de localizaciones extra digestivas que simulan una hemorragia digestiva.

Frente a una HD corresponde pensar en diversas etiologías que pueden agruparse de acuerdo a la localización de la misma.

La edad del paciente también nos puede orien-

Causas de falsa hemorragia digestiva

- Colorantes comerciales
- Fármacos (bismuto, rifampicina, ampicilina, carbón activado, hierro)
- Espinaca, chocolate, remolacha, frutos rojos etc.
- Serratia marcerens
- Constipación
- Ingesta de tierra
- Lesiones en mucosa bucal (aftas, gingivitis, traumatismo dental)
- Lesiones en faringe (amigdalitis, angiomias)
- Inestabilidad hemodinámica
- Vía aérea inestable
- Hemorragia masiva
- Deterioro pulmonar o neurológico
- Preparación inadecuada
- Sospecha de perforación intestinal
- Menstruación
- Hematuria
- Epistaxis

• Secundaria a enfermedad sistémica	10%
• Lesiones de Esófago, Estómago y Duodeno	10% al 20%
• Lesiones de Intestino Delgado	20% a 30%
• Lesiones de Colon, Recto o Ano	50%

tar hacia la patología que determina dicha hemorragia. Los niños de menor edad son un grupo vulnerable ante una hemorragia digestiva severa, ya que sus mecanismos de compensación son menos eficaces que en niños mayores.

Clasificación

Existen diferentes maneras de clasificar una HD, todas pueden aportar información sobre el diagnóstico y tratamiento. Describimos algunas de las más importantes.

Según la forma de presentación.

- ✓ Hematemesis: Sangre expulsada con el vómito, desde rojo rutilante hasta degradada por el jugo gástrico de color porráceo. Originada desde el esófago hasta el duodeno.
- ✓ Melena: Expulsión por el recto de heces negra alquitranada y muy maloliente.
- ✓ Hematoquecia o rectorragia: Sangre roja brillante o marrón proveniente del colon, del recto sigmoides o de ambos. Mezclada

Causas de HD según la edad

Recién nacido	Lactantes de 1 a 12 meses	Preescolar	Escolar y adolescentes
Deglución de sangre materna. Déficit de vitamina K. Esofagitis. Gastritis. Úlcera péptica.	Esofagitis. Úlcera gastroduodenal Ingesta de gastrolesivos y cáusticos Gastropatías Várices esofágicas.	Esofagitis. Úlcera gastroduodenal. Ingesta de gastrolesivos y cáusticos. Gastropatías Várices esofágicas. Vasculitis.	Esofagitis. Várices esofágicas. Gastropatías Úlcera gastroduodenal. Desgarro de la mucosa esofágica. Neoplasias.
Enteritis necrotizante. Infección intestinal. Invasión. Sangrado alto. Intolerancia a la proteína leche de vaca.	Duplicación intestinal con mucosa gástrica. Divertículo de Meckel. Intolerancia a Proteína leche de vaca. Diarrea infecciosa. Hiperplasia nodular linfóide Malformaciones vasculares. Fisura anal Enf. Inflamatoria (EI)	Fisura anal. Diarrea infecciosa Pólipos. Anquidismos. Hiperplasia linfonodular. Invasión. EI. Hemorroides. Vasculitis.	Diarrea infecciosa. Pólipos. Fisura anal Hemorroides. EI

con las heces o independiente de ellas. La rectorragia se presenta al final de la evacuación (proctorragia).

Según la localización

- ✓ Alta: El origen del sangrado se encuentra por encima del ángulo de Treitz. Se presenta como hematemesis y/o melena. Pero, si el sangrado es abundante y/o el tránsito intestinal está acelerado, puede manifestarse como hematoquecia. Tener en cuenta que a su vez las HDA se dividen en variceal o no variceal, importante a la hora de implementar tratamiento.
- ✓ Media: El origen del sangrado se encuentra desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Se manifiesta como melena y/o hematoquecia.
- ✓ Baja: El origen del sangrado se encuentra desde la válvula ileocecal hasta el ano. Se manifiesta como hematoquecia o proctorragia.

Hemorragia oculta: es aquella que no pudiendo observarla macroscópicamente, se detecta a través de SOMF positivas. Pueden provenir de cualquier parte del aparato digestivo, y se expresa como anemia ferropénica.

HD de origen oscuro: Es aquella que persiste o recurre y cuyo origen no puede encontrarse luego de haberse realizado una endoscopia alta, baja y tránsito intestinal.

Intensidad

Además de lo señalado, el médico deberá orientarse sobre la intensidad del sangrado.

Leve	< 30% de pérdida del volumen sanguíneo. Presión arterial normal, Incremento del pulso 10-20% del basal. Relleno capilar conservado. Taquicardia >150 ppm, Taquipnea 35-40 rpm
Moderada	30%-45% de pérdida del volumen sanguíneo. Signos del grado leve más Diuresis >1ml/kg/hora
Grave	> 45% de pérdida de volumen sanguíneo. Anemizante, inestabilidad hemodinámica, pulso no palpable, paciente comatoso y relleno capilar prolongado. Disminución de la TA, Hipotensión ortostática. Diuresis < 1ml/kg/h.

Diagnóstico

A la hora de comenzar la evaluación diagnóstica, es necesario repasar algunos conceptos vertidos anteriormente. Se debe interrogar sobre:

- Edad
- Horas de ayuno
- Tos o epistaxis
- Otros síntomas digestivos
- Aspecto de la sangre emitida
- Canalización umbilical
- Ingestión de gastrolesivos o cuerpos extraños
- Antecedentes de enfermedad digestiva o hepática aguda o crónica
- Ingestión de fármacos, alimentos, aditivos y colorantes alimentarios
- Posible ingestión de sustancias tóxicas (fumigadores, ferreteros)
- Síntomas extra digestivos
- Antecedentes familiares

Examen físico y signos sugestivos de la causa del sangrado

- Aspecto general: estigma de hepatopatía crónica (eritema palmar, circulación colateral, spiders), hemangiomas y púrpura.
- Exploración naso-faríngea, evaluando sangrado de nariz o amígdalas.
- Examen abdominal en búsqueda de organomegalias y otros signos.
- Exploración anal y perianal, realizando una buena inspección y si es necesario el tacto rectal para evaluar sangre no eliminada.
- Las características de la materia fecal nos puede orientar en el sitio de origen del sangrado.
- Si la evolución es más prolongada o tórpi-da y con deterioro clínico se debe pensar en enfermedad inflamatoria intestinal.
- Si la hemorragia es masiva las etiologías más habituales serían: Várices esofágicas, úlcera gastroduodenal o un sangrado por divertículo de Meckel, o por un angioma.

Hemorragia digestiva baja	Con dolor	Sin dolor
Buen estado general	Fisura anal	Pólipos intestinales
Mal estado general	Colitis infecciosa o Enf. Inflamatoria(EII)	Divertículo Meckel

Esquema orientativo en HD Baja.

Estudios Complementarios

Los diferentes estudios complementarios desde los más básicos, que se pueden solicitar en cualquier guardia en instituciones hospitalarias y otros estudios complejos o de tercer nivel nos pueden identificar la causa de HD. Estos últimos se sabe que no se encuentran al alcance de todos y que en el sangrado agudo toma mayor importancia la estabilización del paciente.

Es de gran importancia para el pediatra que a la hora de solicitar la consulta con el especialista no debe faltar el hemograma completo y el coagulograma.

Laboratorio:

Hemograma completo

Hemostasia / Grupo y factor

Función hepática

Medio interno / Ionograma

Glucosa, urea y creatinina

Gammacámara Tc99

Eritrocitos marcados

Arteriografía

Tomografía axial computada (TAC)

Angioenterotomografía computada (angioentero-TC)

Radiología:

Simple: Obstrucción/perforación

Tránsito: No en hemorragia aguda

Colon por enema: EII-invaginación

Endoscopias digestivas

Esofagogastroduodenoscopia: Método de elección en niños con sangrado gastrointestinal agudo alto. Mejor pronóstico en primeras 24 horas. Terapéutica en algunos casos.

Colonoscopia (VCC): Método de elección indicada en casos de hematoquecia y sangrado oculto sin causa demostrada. Terapéutica en algunos casos.

Enteroscopia: Este procedimiento ofrece la posibilidad de una visualización directa e intervenciones terapéuticas. En los últimos cinco años, la enteroscopia mono o de doble balón está indicada en pediatría. (Baja disponibilidad)

Capsula endoscópica: Permite evaluar el intestino medio y está indicada realizar en mayores

de 18 meses de edad. La mayoría de los pacientes mayores son capaces de tragar la cápsula, por lo que no necesita ser colocada endoscópicamente. La cápsula endoscópica puede visualizar lesiones sangrantes, pero no ofrece opciones terapéuticas ni permite tomar biopsias.

Contraindicaciones de la endoscopia

- Inestabilidad hemodinámica
- Vía aérea inestable
- Hemorragia masiva
- Deterioro pulmonar o neurológico
- Preparación inadecuada
- Sospecha de perforación intestinal

Laparoscopia y laparotomía exploradora:
No suelen estar indicadas en una HDA; los únicos casos serían los de hemorragia severa, cuando existiera una perforación, que hubiera una contraindicación absoluta para la endoscopia o cuando se sospechara una hemorragia media no identificada por los estudios anteriores.

Tratamiento

Hemorragia digestiva alta

Mayormente los cuadros de hemorragia digestiva son auto limitados y solo necesitan observación; sin embargo otros requieren medicación y un manejo endoscópico activo.

Manejos iniciales:

- ✓ Control constante de signos vitales
- ✓ Alimentación: aconsejable ayuno
- ✓ Catéteres venosos: 1-2 vías periféricas cortas y gruesas
- ✓ Reserva de concentrados de hemáties
- ✓ Analítica con pruebas de coagulación
- ✓ No colocar sonda nasogástrica ante la sospecha de HDA variceal
- ✓ Reposición de la volemia. Infusión de 15-20ml/ kg de solución fisiológica, hasta disponer de sangre o glóbulos sedimentados

En hemorragia grave, valorar: oxigenoterapia, vía central, sonda vesical, intubación traqueal o necesidad de ingreso en unidad de cuidados intensivos.

En la HDA variceal la transfusión de glóbulos

rojos debe ser conservadora con un nivel objetivo de hemoglobina entre 7 y 8 g / dL, hematocrito de 24% aunque la política de transfusión en pacientes individuales también debe considerar otros factores como comorbilidades (particularmente enfermedad pulmonar subyacente o cardiopatía congénita cianótica), Edad, estado hemodinámico y sangrado continuo.

Supresión de secreción ácida o citoprotectores.

Manejo específico de la hemorragia digestiva alta no variceal

HEMORRAGIA LEVE (Riesgo bajo): Tratamiento médico (supresión ácida o cito protectores):
Omeprazol: 2 mg / kg / día cada 24 hs IV/ VO
Ranitidina: Intravenoso 2-4 mg/kg/día administrados cada 6-8 horas; máx. 200 mg/día. Vía oral 4-8 mg/Kg/día repartidos en 2 dosis, máx. 300 mg /día.

Sucralfato: Suspensión 1 gr / 5 ml (luego de realizar VEDA)

Conducta expectante: Inicio de alimentación tras endoscopia y alta precoz. La alimentación no aumenta el riesgo de recidiva hemorrágica, pero se considera prudente mantener dieta líquida por si fuera necesario realizar nueva endoscopia o cirugía.

HEMORRAGIA MODERADA: Tratamiento médico -Tratamiento endoscópico: Inyectable: etanol, polidocanol, adrenalina. Mecánico: hemoclip. Térmicos: sonda bipolar, sonda térmica, argón plasma. Se recomienda que los pacientes de alto riesgo por criterios endoscópicos permanezcan hospitalizados al menos 5 días (Tiempo considerado para paso de lesión de alto riesgo a una de bajo riesgo). El 60-76% de las recidivas lo hacen dentro de los primeros 5 días.

HEMORRAGIA GRAVE: Ingreso a UTI. Compensación hemodinámica. En 10-20% la endoscopia no tiene éxito terapéutico, por acceso inadecuado al sitio de sangrado.

Intensidad	Clasificación	Tratamiento
Moderada	Forrest 1 a - 1 b - 2a	Endoscopico + Médico
Leve	Forrest 2 b - 2 c - 3	Médico

Úlcera gastroduodenal

Manejo específico de la hemorragia alta digestiva variceal

Profilaxis antibiótica

Debe mantenerse un alto índice de sospecha de infección bacteriana en la hemorragia por varices agudas en pacientes cirróticos, lo que permite la institución oportuna de terapias antibacterianas. Disminuye la tasa de resangrado.

Ceftriaxona 80 a 100 mg / kg / día ev cada 24 hs. Previa realización de cultivos.

Vasoconstrictores espláncnicos

Octreótido	De elección. Por 5 días. Fotoprotección. Control estricto de TA y glucemia.
Somastostatina	No diluir en suero glucosado Puede producir náuseas, rubor facial, vértigos, hipoglucemia inicial seguida de hiperglucemia a las 2 – 3 horas, vigilar TA y glucemia. Duración máxima del tratamiento de 5 días
Terlipresina	Poca experiencia en niños pequeños. Como efectos colaterales, puede haber vasoconstricción en otras áreas vasculares, como cerebro, extremidades e intestino.

Tratamiento endoscópico

El método a elegir debe ser el que tenga mayor experiencia el endoscopista.

Ligadura con bandas: El método más utilizado y de elección actualmente. Tiene la particularidad de utilizarse en mayores de 10 kg y variable disponibilidad en algunos centros.

Sustancias esclerosantes: Se utiliza cuando no hay disponibilidad de ligadura endoscópica o pacientes menores de 10 kg. El agente más utilizado es el polidocanol al 1%; se inyectan de 0,5 ml a 1 ml/kg/sesión, máximo de 20 ml/sesión. Efecto adverso: disfagia, ulcera, perforación.

La inyección con n-butil-2 cianoacrilato; se utiliza en las varices de techo gástrico, que son menos frecuentes pero de difícil manejo. Se solidifica al estar en contacto con la sangre y ocluye físicamente la luz de la várice. Solo en personal

muy entrenado en este método.

Opciones terapéuticas si falla el tratamiento endoscópico

Balón Sangstaken-Blakemore: Debe usarse en sangrado severo con paciente inestable luego de estabilizado el paciente y de una endoscopia fallida como “puente” temporal hasta que se pueda instituir un tratamiento definitivo o no hay posibilidad de tratamiento endoscópico (por un máximo de 24 horas, preferiblemente en un centro de cuidados intensivos).

Endovascular: El sangrado persistente a pesar de la terapia combinada farmacológica y endoscópica es mejor manejado por la derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) con stents cubiertos con politetrafluoroetileno (PTFE).

Cirugía: El fracaso de erradicación, TIPS o la falta de experiencia local en TIPS en niños pequeños requiere considerar la derivación porto sistémica emergente.

Trasplante Hepático.

Manejo de la hemorragia digestiva media y baja

Ante una hemorragia baja el primer paso será valorar el estado hemodinámico del paciente y tomar las medidas correspondientes. Anamnesis. Examen clínico. Valorar pérdidas. Descartar HDA

- Estabilización del paciente.
- Tratamiento médico correspondiente. (ej.: Fisuras anales, APLV, EII, etc.)
- Endoscopia diagnóstica y terapéutica: El tratamiento endoscópico estaría indicado, principalmente, en la polipectomía.
- Tratamiento quirúrgico correspondiente. (ej: Meckel, MAV, etc.).

Conceptos importantes

- ✓ Valorar hemorragias digestivas verdaderas o falsas.
- ✓ Todo niño con HDA debe ser internado y estudiado a la brevedad; con las HDB, solo cuando comprometen la volemia o sospecha de sangrado de intestino Medio.
- ✓ HDB con características de sangrado rectal deben ser estudiadas, pero sin carácter de emergencia.
- ✓ Ante una HDA o media, la derivación al

especialista debe ser inmediata.

- ✓ La clínica del paciente no se corresponde con la cantidad de sangrado por lo que no se debe subestimar.
- ✓ Estabilizar el paciente.
- ✓ No debe faltar el hemograma completo y el coagulograma, que se encuentra al alcance de todos a la hora de solicitar interconsulta con el especialista junto con antecedentes personales.

Bibliografía

-

An update on the management of acute esophageal variceal bleeding. Gastroenterol Hepatol. 2016.

Baveno VI consensus: Journal of Hepatology 2015 vol. 63 j 743-752-
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.07.001>.

Consenso Nacional de Urgencias Endoscópicas en Pediatría 2016- Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 1:S1-S26 / S1

Hipertensión Portal en niños: opinión pediátrica experta sobre el informe del taller de consenso de Baveno v en Metodología del diagnóstico y la terapia en hipertensión portal-Transplante de pediatría. 2012 Ago; 16 (5): 426-37. doi: 10.1111 / j.1399-3046.2012.01652.x. Epub 2012 13 de marzo.

Readmission after Gastrointestinal Bleeding in Children: A Retrospective Cohort Study-FLA 5.4.0 DTD

***Dr. Lucas Ruiz**

Pediatra Gastroenterólogo infantil

****Dra. Viviana Bernedo**

Gastroenteróloga infantil

HEPATITIS VIRALES

Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón de San Martín.

Servicio de Pediatría



Dra. Antonella Soledad Antonelli Sanz

Dra. María Candela Cogley

Dr. Leonel Romero Roldán

Residentes

Dra. María Cecilia Eiras

Instructora de Residentes

Dra. María Lorena Cavalieri*

Revisora

Sumario

Las hepatitis virales son causadas principalmente por virus hepatotrópos, pero existen otros virus que provocan enfermedad extrahepática, causando en algunas ocasiones hepatitis. Para llegar al correcto diagnóstico, es importante realizar un amplio interrogatorio sobre antecedentes personales, familiares, epidemiológicos y exposición a tóxicos, así como también un examen físico completo para evaluar signos de enfermedad hepática crónica.

Durante el seguimiento de los pacientes con hepatitis virales, es importante evaluar la mejoría del hepatograma, para detectar los casos de mala evolución y derivarlos a tiempo al hepatólogo infantil.

La mejor prevención es proporcionar alimentos, agua y condiciones sanitarias seguras, vacunación, detección precoz de madres portadoras y control de infecciones en donaciones de sangre.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 10 meses de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia, que consulta inicialmente por un cuadro de vía aérea superior (CVAS), vómitos y fiebre de 5 días de evolución. Al examen físico se encuentra febril, se constata CVAS, presenta adenopatías móviles de consistencia duro-elásticas, no adheridas a planos profundos y sin signos de flogosis, en regiones submaxilar, retroauricular e inguinal. Fauces y otoscopia normales. Se palpa polo de bazo y hepatomegalia 2 cm por debajo del reborde costal. La niña concurre a la guardería, pero la mamá no sabe si hubo otros niños enfermos. Al interrogatorio la madre niega viajes y tóxicos. Como antecedentes patológicos familiares, hermana mayor de 8 años con diabetes tipo 1 y madre con hipotiroidismo. Se solicita laboratorio: leucocitos 12400/mm³, aspartatoaminotransferasa (AST) 110 UI/l, alaninoaminotransferasa (ALT) 205 UI/l, bilirrubina total 0,8 mg/dl, bilirrubina directa 0,2 mg/dl, coagulograma y función renal, normales. Debido a la clínica

de la niña y los hallazgos de laboratorio se solicitaron serologías para hepatitis A, B, C, Epstein Barr (EBV) y citomegalovirus (CMV). Se obtuvieron como resultado IgG e IgM para CMV positivas y el resto de las serologías, negativas. Se realizó ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño, homogéneo, esplenomegalia homogénea con diámetro de 90 mm. Resto normal.

Se interpretó el cuadro como hepatitis por CMV asociado a síndrome mononucleósico. La niña continuó seguimiento en forma ambulatoria con buena evolución clínica, normalizando al mes el hepatograma.

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones de la función y la estructura hepáticas pueden ser agudas o crónicas. En las hepatitis agudas, se observa un proceso inflamatorio difuso del parénquima hepático, de gravedad variable. Las lesiones hepatocitarias pueden deberse a una infección viral, fármacos, toxinas, hipoxia, trastornos inmunológicos o errores congénitos del metabolismo. Los virus hepatotrópos, A, B, C, D y E son los principales responsables de enfermedad específica hepática viral. La infección por virus B o C pueden progresar a hepatitis crónica y favorecer el desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma. Otros virus como el adenovirus, rubéola, sarampión, varicela, parvovirus, CMV y EBV, entre otros, pueden producir afectación hepática, que suele resolverse en varias semanas.

Clínica

La mayoría de las hepatitis agudas virales se presentan como formas anictéricas, con signos y síntomas ausentes o inespecíficos, como astenia, anorexia, fiebre, náuseas, vómitos y/o diarrea. En las presentaciones ictéricas, generalmente precedidas por pródromos inespecíficos, la ictericia, coluria, hipo/acolia y hepatomegalia dominan el cuadro clínico.

Diagnóstico

Durante el interrogatorio inicial, se deben recabar datos epidemiológicos, antecedentes de ictericia, epistaxis, hematomas, hemorragia digestiva, manifestaciones digestivas, cutáneas, articulares u otras, así como de viajes, transfusiones, tratamientos quirúrgicos, odontológicos, tatuajes, piercings, medicamentos, infusio-

nes con hierbas o sustancias ilícitas. A su vez, se debe indagar sobre posibles antecedentes familiares de enfermedades hepáticas, metabólicas o autoinmunes. Al examen físico, puede constatar ictericia, lesiones por rascado y hepatomegalia dolorosa.

Se confirmará el diagnóstico con la determinación de transaminasas séricas que, en el caso de infección por virus hepatotrópos, suelen estar muy elevadas (por encima de 10 veces el límite superior de la normalidad). Generalmente, hay una inversión del cociente AST/ALT con predominio de esta última. De forma transitoria se observan neutropenia, linfopenia y posteriormente, linfocitosis relativa.

El nivel total de transaminasas carece de importancia pronóstica, ya que pacientes con niveles muy altos pueden evolucionar bien en un corto período de tiempo, mientras que otros con niveles menores pueden tener una evolución tórpida. Su brusco descenso, asociado a un aumento de las cifras de bilirrubina y alargamiento del tiempo de protrombina, son signos de mal pronóstico.

Puede evidenciarse una fase de colestasis, definida por la elevación de los niveles séricos de bilirrubina conjugada, fosfatasa alcalina (FAL), 5-nucleotidasa, gamma glutamil transferasa (GGT) y urobilinógeno. Se debe a un flujo biliar anormal a nivel canalicular y celular, ocasionado por lesión hepática y mediadores inflamatorios.

Los marcadores de la alteración de la función hepática son: la síntesis proteica anormal (tiempo de protrombina prolongado, índice normalizado internacional (INR) elevado, bajas concentraciones séricas de albúmina), trastornos metabólicos (hipoglucemia, acidosis láctica, hiperamonemia) y alteración del nivel de conciencia con aumento de los reflejos tendinosos profundos (encefalopatía hepática). La monitorización de la función sintética debe ser el centro principal en el seguimiento clínico para definir la gravedad de la enfermedad.

Diagnósticos diferenciales

Los diagnósticos diferenciales varían con la edad de presentación. En el período neonatal, la infección es una causa común de hiperbilirrubinemia NO conjugada; la causa infecciosa puede ser un agente bacteriano (p.ej., *Escherichia Coli*, *Listeria*, *Treponema Pallidum*) o un virus

no hepatotropos (p. ej., virus del herpes simple, enterovirus, CMV). Siempre se deben excluir las causas metabólicas (déficit de α 1-antitripsina, fibrosis quística, tirosinemia), anatómicas (atresia biliar, quistes del colédoco) y hereditarias de colestasis intrahepática. En las últimas etapas de la infancia se deben excluir la obstrucción extrahepática (cálculos biliares, colangitis esclerosante primaria), afecciones inflamatorias (hepatitis autoinmune, artritis reumatoide juvenil, enfermedad de Kawasaki), trastornos infiltrativos (tumores malignos), toxinas/medicamentos, trastornos metabólicos (fibrosis quística) o una infección (sífilis, Epstein-Barr, varicela).

PRINCIPALES TIPOS DE HEPATITIS VIRALES

Los virus A y E se denominan virus de la hepatitis “entéricos”, ya que se transmiten por vía fecal-oral a través del agua o alimentos contaminados, favorecidos por el hacinamiento y malas condiciones sanitarias.

HEPATITIS A ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

El virus de la hepatitis A (VHA) perteneciente a la familia de los picornavirus, es el virus hepatotrópo más prevalente. Es también el responsable de la mayoría de las formas de hepatitis agudas y benignas; la insuficiencia hepática fulminante es infrecuente. Es altamente contagioso. Tiene una distribución mundial, pero es más prevalente en países en vías de desarrollo.

La infección por hepatitis A en Argentina ha sido siempre considerada de intermedia a alta endemicidad. Es de destacar que durante los años 2003 y 2004 fue documentado un brote a nivel nacional. Con el fin de reducir la morbimortalidad asociada a esta infección endémica en la región, en junio de 2005, el Ministerio de Salud de la Nación introdujo la vacuna anti VHA al calendario oficial de vacunación, con esquema de una única dosis a los 12 meses de vida. Antes de la implementación del programa de vacunación, la hepatitis fulminante (HF) por Hepatitis A era la indicación más frecuente de trasplante hepático en la población pediátrica (49.9%) con un pico en el número de casos durante el año 2004, coincidiendo con el brote nacional de VHA. Durante los últimos años se observó una disminución progresiva del número de casos de HF por

VHA y en el período de noviembre de 2006 a diciembre de 2008 no se registraron nuevos casos de trasplante hepático por Hepatitis A. Esta situación ha permanecido sin cambios hasta la actualidad.

La transmisión es por contacto interpersonal, por vía fecal-oral. El promedio del período de incubación del VHA es de unas 3 semanas. La excreción fecal del virus comienza tarde en el período de incubación, alcanza su máximo justo antes del comienzo de los síntomas y se resuelve a las 2 semanas después del comienzo de la ictericia en los pacientes de más edad. La duración de la excreción vírica es prolongada en los lactantes.

PATOGENIA

La respuesta aguda del hígado a los virus hepatotrópos implica una lesión citopática directa, así como una lesión de mediación inmunitaria, con afectación difusa del hígado. Es común la proliferación de conductos biliares, pero no su lesión. El hígado retorna a su morfología normal en 3 meses desde el comienzo de la infección aguda.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El VHA sólo causa hepatitis aguda. Con frecuencia se trata de una enfermedad anictérica, con síntomas clínicos indistinguibles de otras formas de gastroenteritis vírica, sobre todo en los niños pequeños. Se trata mayormente de una enfermedad aguda, febril, con un comienzo súbito de anorexia, náuseas, malestar, vómitos e ictericia. La duración típica de la enfermedad es de 7-14 días. Puede haber adenomegalias regionales y esplenomegalia. La médula ósea puede hallarse moderadamente hipoplásica y se ha descrito anemia aplásica.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la infección aguda se realiza mediante la detección de anticuerpos frente al VHA, específicamente inmunoglobulina (IgM) anti-VHA, los cuales permanecen positivos durante 4-6 meses después de la infección aguda. Se suele detectar un anti-VHA neutralizante (IgG) en las 8 semanas siguientes al comienzo de los síntomas y se determina como parte del anti-VHA total en el suero, la cual le confiere protección a largo plazo. Casi siempre aumentan los niveles de ALT, AST, bilirrubina, fosfatasa

alcalina, 5-nucleotidasa y GGT, que no son útiles para diferenciar la causa de la hepatitis.

COMPLICACIONES

La mayoría de los pacientes se recuperan por completo. Sin embargo, pueden producirse 2 complicaciones distintas. La insuficiencia hepática aguda (IHA) es una complicación rara pero no infrecuente del VHA. Los pacientes con riesgo de esta complicación son adolescentes y adultos, pero también los pacientes inmunodeprimidos o aquellos con trastornos hepáticos de base. El VHA también puede progresar a un síndrome de colestasis prolongada que permanece por varios meses. El prurito y la malabsorción de grasa son problemáticos y requieren soporte sintomático. Este síndrome se da en ausencia de cualquier disfunción de la síntesis hepática y se resuelve sin dejar secuelas.

TRATAMIENTO

No hay tratamiento específico para la hepatitis A sino de soporte, que consta de hidratación intravenosa a demanda, junto con agentes anti-pruriginosos y vitaminas liposolubles para la forma colestásica prolongada de la enfermedad. Se recomienda una monitorización seriada en busca de signos de IHA y una eventual remisión temprana a un centro de trasplantes.

PREVENCIÓN

Los pacientes infectados por el VHA son contagiosos desde 2 semanas antes y hasta aproximadamente 7 días después del comienzo de la ictericia y deben ser excluidos de la escuela, las guarderías o el trabajo durante este período. Es necesario el lavado de manos, sobre todo después de cambiar los pañales y antes de preparar o servir la comida. En el medio hospitalario se recomiendan las precauciones de contacto y habituales durante 1 semana después del comienzo de los síntomas.

Las indicaciones para la administración intramuscular de Inmunoglobulina (0,02 ml/kg) son la profilaxis pre y postexposición. La Ig se recomienda para la profilaxis preexposición de las personas susceptibles que viajen a países donde el VHA es endémico y proporciona una protección eficaz hasta 3 meses. La vacuna contra el VHA administrada en cualquier momento antes del viaje es la opción preferida como profilaxis preexposición en personas sanas, pero la

Ig proporciona una profilaxis adecuada en niños menores de 1 año, pacientes alérgicos a los componentes de la vacuna o aquellos que prefieran no vacunarse. La Ig como profilaxis en situaciones postexposición se debería utilizar lo antes posible (no es eficaz luego de 2 semanas postexposición). Se usa de forma exclusiva en niños menores de 12 meses, huéspedes inmunodeprimidos, pacientes con hepatopatía crónica o en quienes tengan contraindicaciones para la vacuna. La disponibilidad de dos vacunas frente al VHA inactivadas, muy inmunógenas y seguras, ha tenido un enorme impacto sobre la prevención de la infección por VHA. Se administra en una única dosis a los 12 meses de vida y se encuentra en el calendario nacional de vacunación.

HEPATITIS B

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

El virus de la Hepatitis B (VHB) es miembro de la familia Hepadnaviridae y tiene un genoma de ADN circular parcialmente bicatenario. Se han identificado 4 genes que codifican para 4 proteínas de relevancia: S (superficie), C (núcleo), X y P (polímero). La superficie del virus tiene partículas denominadas antígenos de superficie de la hepatitis B (HBsAg). La porción interna del virión contiene antígeno nuclear de hepatitis B (HBcAg), la nucleocápside que codifica el ADN vírico y un antígeno no estructural denominado antígeno e de hepatitis B (HBeAg). El HBeAg es útil como marcador de la replicación vírica activa y suele correlacionarse con los niveles de ADN del VHB. La replicación del VHB tiene lugar sobre todo en el hígado, y también en linfocitos, bazo, riñones y páncreas.

El VHB se ha detectado en todo el mundo. Se estima que 400 millones de personas presentan infección crónica. Se producen alrededor de un millón de muertes por año por este virus y es responsable de más del 80% de los casos de hepatocarcinoma.

Las regiones de mayor prevalencia de infección por VHB son África subsahariana, China, zonas de Oriente Medio, la cuenca del Amazonas y las islas del Pacífico. Argentina se considera un país de baja prevalencia, ya que la detección del antígeno de superficie de virus de la hepatitis B (HBsAg) es menor al 2% en los donantes de sangre. Se cree que el número de casos nuevos anuales en niños es bajo, pero es difícil de deter-

minar porque muchas de las infecciones infantiles son asintomáticas.

El VHB se halla presente en elevadas concentraciones en la sangre, suero y exudados serosos, y en concentraciones moderadas en saliva, exudado vaginal y semen. Se produce una transmisión eficaz por la exposición a la sangre y el contacto sexual. En países de baja prevalencia, como Argentina, la vía de transmisión más importante es la sexual (50%). Los factores de riesgo para la infección por el VHB en niños y adolescentes incluyen el uso de drogas intravenosas o hemoderivados, la acupuntura o los tatuajes con agujas contaminadas, el contacto sexual, los cuidados en instituciones y el contacto estrecho con portadores. Según datos del CDC, el 42% de las hepatitis B crónicas del adulto han sido adquiridas durante la infancia. El factor de riesgo principal para adquirir el VHB en niños sigue siendo la exposición perinatal cuando la madre es HBsAg-positiva. El riesgo máximo de transmisión se da cuando la madre también es portadora del antígeno HBeAg; hasta el 90% de los lactantes de estas madres desarrolla una infección crónica si no se les trata; se produce una infección intrauterina en el 2,5% de estos lactantes. En la mayoría de los casos, los marcadores serológicos de infección y la antigenemia aparecen 1-3 meses después del nacimiento, lo que sugiere que la transmisión ha ocurrido en el momento del parto; la fuente puede ser el virus presente en el líquido amniótico, en las heces o en la sangre de la madre.

PATOGENIA

Después de la infección, el período de incubación varía entre 45 y 160 días (media 120 días). La respuesta aguda del hígado al VHB es la misma que frente a todos los virus hepatotrópos. El VHB, a diferencia de otros virus hepatotrópos, es un virus predominantemente no citopatógeno que lesiona sobre todo por procesos inmunomediados. La gravedad de la lesión del hepatocito refleja el grado de respuesta inmunitaria; cuanto mayor es ésta, mayor es la probabilidad de eliminación del virus y más grave es la lesión en los hepatocitos. El primer paso en la hepatitis aguda es la infección de los hepatocitos por el VHB, que da lugar a la expresión de antígenos víricos en la superficie celular, siendo los principales el HBcAg y el HBeAg de la nucleocápside, que junto con las proteínas del complejo princi-

pal de histocompatibilidad de clase I convierten a la célula en el objetivo de la lisis por linfocitos T citotóxicos.

El mecanismo de desarrollo de hepatitis crónica no se conoce completamente. Existe fenómeno de tolerancia en los casos adquiridos perinatalmente, lo que da lugar a una elevada incidencia de infección persistente en niños, con inflamación escasa o nula del hígado, enzimas hepáticas normales y carga viral muy elevada. Los infectados crónicos muestran a lo largo de su vida diferentes estados o fases. Los cambios de fase se atribuyen a cambios en la capacidad de reconocimiento inmunológico del huésped.

– La fase de alta replicación se define por la presencia de HBeAg, y una alta carga viral (ADN-VHB $\geq 10^5$ copias/ml o >20.000 UI/ml). Los valores de ADN-VHB habitualmente son $>10^8$ copias/ml. Las transaminasas son elevadas y en la biopsia hay inflamación. Los niños infectados por vía perinatal pueden tener durante los primeros años o décadas en esta fase un estado de normalidad funcional e histológica atribuido a inmunotolerancia. La duración de la fase replicativa es variable, generalmente inferior a 10 años salvo en los casos de infección vertical.

– La fase de inmunoeliminación es definida por el descenso de la carga viral, que precede a la negativización de HBeAg (“aclaramiento de HBeAg”) y aparición de Ac antiHBe (“seroconversión”). En esta fase tiene lugar la mayor intensidad de necro-inflamación y disfunción.

– La fase de baja replicación (portador): Se define por la negatividad de HBeAg, positividad del Ac antiHBe y ADN-VHB indetectable o detectable $\leq 10^4$ copias/ml o 2.000 UI/ml. La función hepática es normal, o con mínimas alteraciones ocasionales. En la biopsia se observa un hígado normal, o con leve inflamación. En algunos casos, el proceso inflamatorio de las fases previas ha producido fibrosis significativa o cirrosis.

– Reactivación: tras un tiempo de normalidad funcional en los portadores con Ac antiHBe+, puede reaparecer disfunción asociada a un nivel replicativo del virus mayor, con ADN-VHB $>10^5$ copias/ml. La reactivación de la replicación viral puede ocurrir en el virus salvaje (con reversión al estado HBeAg+) o, mucho más frecuente, por mutación viral manteniendo Ac antiHBe+.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Muchos casos agudos de infección por VHB

en niños son asintomáticos, como se demuestra por la elevada tasa de pacientes con marcadores séricos en ausencia de antecedentes de hepatitis aguda. El episodio sintomático agudo habitual es similar al de las infecciones por VHA y VHC, aunque puede ser más grave y es más probable que afecte a la piel y las articulaciones. La primera prueba bioquímica de infección por el VHB es la elevación de los niveles de ALT, que empiezan a aumentar justo antes de la aparición de fatiga, anorexia y malestar, que tienen lugar alrededor de 6-7 semanas después de la exposición. En algunos niños, la enfermedad puede estar precedida de artralgia o lesiones cutáneas, como urticaria o erupción purpúrica, macular o maculopapular. También pueden producirse enfermedades extrahepáticas, como una acrodermatitis papular (Síndrome de Gianotti-Crosti), poliarteritis nodosa, glomerulonefritis y anemia aplásica. La ictericia, que puede existir en alrededor del 25% de los pacientes infectados, comienza alrededor de la 8va semana tras la exposición y dura unas 4 semanas. En la evolución habitual de la resolución de la infección por VHB los síntomas duran 6-8 semanas.

DIAGNÓSTICO

El perfil serológico de la infección por VHB varía en función de si la enfermedad es aguda o crónica. Para confirmar el diagnóstico de infección aguda por VHB se utilizan múltiples marcadores serológicos (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs). El primer marcador que aparece es el HBsAg, que se encuentra en casi todas las personas infectadas; su elevación coincide estrechamente con el comienzo de los síntomas. La persistencia del HBsAg más de 6 meses define el estado de infección crónica. Durante la recuperación de la infección aguda, debido a que los niveles de HBsAg disminuyen antes de que desaparezcan los síntomas, el anticuerpo IgM contra HBcAg (IgM anti-HBc) podría ser el único marcador de infección aguda. La IgM anti-HBc se eleva poco después de la infección y permanece positiva durante muchos meses antes de su sustitución por IgG anti-HBc, que persiste durante años. Por tanto, el anti-HBc es un marcador serológico útil de infección aguda por VHB. El anti-HBs marca la recuperación serológica y la protección. Las personas inmunizadas con vacuna de la hepatitis B sólo tienen anticuerpos anti-HBsAg, mientras que en aquéllas con una infección resuelta

se detectan anti-HBs y anti-HBc. El HBeAg se halla presente en las infecciones activas agudas o crónicas y es un marcador de infectividad. El desarrollo de anti-HBe (denominado seroconversión) señala la mejoría, y es un objetivo del tratamiento en los pacientes con infección crónica.

COMPLICACIONES

La insuficiencia hepática aguda (IHA) con coagulopatía, encefalopatía y edema cerebral es más frecuente por VHB que por el resto de los virus hepatotrópos. El riesgo de IHA aumenta cuando hay infección simultánea o sobreinfección por VHD. La infección por el VHB puede causar también hepatitis crónica.

El riesgo de infección crónica es del 90% en niños menores de 1 año; del 30% en los niños de 1-5 años y del 2% en los adultos. La infección crónica se asocia con el desarrollo de hepatopatía crónica y de carcinoma hepatocelular (CHC). El riesgo de carcinoma es independiente de la presencia de cirrosis. Uno de cada cuatro portadores crónicos del VHB desarrollará secuelas serias a lo largo de su vida.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la infección aguda es en gran medida de soporte, con monitorización estrecha de la insuficiencia hepática. En la actualidad, ningún fármaco logra la erradicación completa del virus. El tratamiento de la infección crónica debe ser individualizado y efectuado junto con un hepatólogo infantil. El objetivo del tratamiento es reducir la replicación viral, definida por la ausencia de ADN viral detectable en suero y el desarrollo de anti-HBe (seroconversión). El desarrollo de anti-HBe transforma la enfermedad en una forma inactiva, por lo que disminuye la infectividad, la lesión hepática activa y la inflamación, la progresión a fibrosis y el riesgo de CHC.

PREVENCIÓN

Medidas generales

Detección obligatoria del HBsAg en bancos de sangre, en todas las embarazadas al menos una vez en el tercer trimestre de cada embarazo. Uso de material descartable. Se aconseja, además, la práctica de las "medidas universales de prevención", cualquiera sea la patología que presente el paciente.

Vacunación

Las vacunas anti-hepatitis B utilizadas en la actualidad son de tipo recombinante y elaboradas por ingeniería genética. La vacuna tiene una eficacia del 90-95% para prevenir la infección por HBV. Se considera que el nivel de anticuerpos protectores es adecuado con valor mayor de 10 mUI/ml.

El esquema habitual es el de 3 dosis: las 2 primeras con intervalo de 1 mes y la tercera a los 6 meses de la primera (0-1-6 meses). Nuestro país ha implementado la vacunación obligatoria de todos los RN dentro de las 12 hs posteriores al parto con el objetivo de prevenir la transmisión perinatal, la segunda dosis 1-2 meses después de la primera y la tercera a los 6 meses de vida. La dosis de vacuna neonatal debe ser únicamente monovalente.

En 2003 se incorporó al calendario la vacunación de los preadolescentes, que no la hubieran recibido en el momento del nacimiento, a los 11 años. En el año 2014 la vacuna fue oficialmente incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para toda la población adulta, con carácter gratuito y obligatorio.

El RN de madre HBsAg (+) debe recibir gammaglobulina hiperinmune para HBV (0,5 ml, vía IM) en las primeras 12 horas después del nacimiento junto con la vacuna y en sitios separados de inyección. La transmisión de la infección puede evitarse en cerca del 95% de los hijos de madres con HBsAg positivo, con la inmunoprofilaxis temprana activa y pasiva del neonato. La vacuna contra HBV, aplicada dentro de las 12 horas del nacimiento, tiene gran eficacia para evitar las infecciones perinatales, dato para tener en cuenta ante las dificultades de provisión de la IGHB.

Inmunoglobulina anti-hepatitis B (IGHB)

Su utilización asociada a la vacuna se aconseja en las siguientes situaciones:

- RN cuyas madres son HBsAg (+).
- Contactos familiares de personas con infección aguda por VHB.
- Contactos sexuales de personas con infección por VHB.
- Exposición percutánea o mucosa con sangre HBsAg (+) o fuente desconocida.

HEPATITIS C

El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de

ARN monocatenario, clasificado como un género distinto de la familia Flaviviridae. Presenta seis genotipos principales y numerosos subtipos y especies, lo que permite que el virus escape a la vigilancia inmunitaria del huésped. La variación genotípica puede explicar en parte las diferencias en el curso clínico y en la respuesta al tratamiento.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por VHC es un problema de salud pública a nivel mundial y se estima que existen más de 170 millones de individuos infectados. Su incidencia y prevalencia varían de acuerdo con las diferentes regiones geográficas. La prevalencia global en Argentina se estima en 2%. Este virus es la causa más frecuente de hepatitis crónica en el mundo occidental y el principal agente de las hepatitis no A-no B (NANB) de transmisión parenteral.

PATOGENIA

El patrón de la lesión hepática aguda es indistinguible del de otros virus hepatotrópos. En los casos crónicos se encuentran agregados folículos linfoides en los tractos portales. Con frecuencia también se observa esteatosis en estas muestras hepáticas. El VHC parece causar lesión principalmente mediante mecanismos citopáticos, aunque en ocasiones éstos son inmunomediados. El componente citopático parece ser leve, ya que la enfermedad aguda suele ser la menos grave de todas las infecciones por virus hepatotrópos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La infección aguda por VHC tiende a ser leve y de comienzo insidioso. Rara vez se produce IHA. Sin embargo, el VHC es el virus hepatotrópo con mayor probabilidad de causar infección crónica. En adultos infectados menos del 15% eliminan el virus; el resto desarrolla hepatitis crónica. En estudios pediátricos el 6-19% de los niños logró una eliminación sostenida espontánea del virus durante un seguimiento de 6 años.

DIAGNÓSTICO

Las pruebas se basan en la determinación de anticuerpos frente a antígenos del VHC o en la detección de ARN. La detección de anticuerpos anti-HCV por técnica de ELISA implica que el paciente ha estado expuesto a este virus. Tie-

ne una sensibilidad de 97-100%. Su positividad no permite distinguir entre enfermedad aguda, crónica o resuelta.

El análisis virológico más utilizado para el VHC es un análisis por PCR. La detección con PCR cualitativa es especialmente útil y muy sensible en pacientes con infección perinatal o reciente, hipogammaglobulinemia o inmunosupresión. La PCR cuantitativa ayuda a identificar a los pacientes con probabilidad de responder al tratamiento y a monitorizar la respuesta a éste.

El diagnóstico de infección vertical por VHC en lactantes expuestos, debe diferenciarse de la transmisión pasiva de anticuerpos maternos durante el embarazo, que pueden persistir hasta los 13-18 meses de vida. La determinación del ARN VHC por técnica de PCR es altamente específica para el diagnóstico diferencial pero su sensibilidad es baja en los primeros días de vida (22%), aumentando a partir del mes y en adelante al 75% o más (un RN se considera infectado si el ARN VHC sérico es positivo, en al menos 2 determinaciones separadas, entre los 2 y 6 meses de vida, con persistencia de los anticuerpos anti-VHC después del primer año).

TRATAMIENTO

La historia natural de la infección por VHC en niños aún se está por definir. Se cree que los niños tienen una mayor tasa de eliminación espontánea del virus que los adultos (hasta el 45% hacia los 19 años). La hepatitis C crónica es lentamente progresiva durante la infancia y no existe consenso mundial en relación con el momento ideal del comienzo del tratamiento. En ausencia de otras noxas que dañen al hígado, la progresión de la fibrosis parece estar relacionada con la duración de la infección. El objetivo del tratamiento es lograr la desaparición de la viremia (ARN VHC en suero por debajo de 30-50 UI/ml por técnica de PCR), reversión o no progresión de la fibrosis hepática, evitando la evolución a la cirrosis y el hepatocarcinoma. Recientemente, la FDA y la EMEA han aprobado en los niños el tratamiento combinado con IFN alfa Pegilado (PEG Interferón) más Ribavirina; el cual ha demostrado ser más eficaz en la obtención de la respuesta virológica sostenida (RVS, ARN indetectable 24 semanas luego de finalizado el tratamiento) que la monoterapia con IFN alfa. La ventaja del PEG Interferón es su mayor vida media, que permite la administración semanal.

HEPATITIS D

Este virus es incapaz de fabricar su propia cubierta proteica; su capa externa la forma el exceso de HBsAg procedente del VHB. Por tal motivo, es incapaz de producir infección sin la concurrencia del VHB. El núcleo interno del virus es ARN circular monocatenario que expresa el antígeno del VHD.

EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGENIA

El VHD puede producir infección simultánea con la primoinfección por VHB (coinfección) o bien infectar a una persona previamente infectada por VHB (sobreinfección). La transmisión suele producirse por contacto entre familiares o por contacto íntimo en zonas de gran prevalencia (países en vías de desarrollo). El periodo de incubación de la sobreinfección por VHD es de alrededor de 2-8 semanas, mientras que en la coinfección es similar al de la infección por VHB. El VHD lesiona directamente por mecanismos citopáticos. Los casos más graves de infección por VHB parecen ser resultado de coinfección por VHB y VHD.

CLÍNICA

Los síntomas de infección por VHD son similares a los producidos por los otros virus hepatotropos, pero por lo general más graves. El curso clínico depende del mecanismo de infección: en la coinfección es habitual la hepatitis aguda, más grave que la infección exclusiva por VHB, pero con bajo riesgo de evolución a infección crónica. En la sobreinfección, la enfermedad aguda es infrecuente, pero la evolución a cronicidad es habitual. Sin embargo, el riesgo de IHA es máximo en la sobreinfección. Debe sospecharse VHD en cualquier niño con IHA.

DIAGNÓSTICO

Se diagnostica por detección de anticuerpos IgM dirigidos contra el VHD. Estos anticuerpos se desarrollan unas 2-4 semanas después de la coinfección y unas 10 semanas tras la sobreinfección.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento se basa en medidas de soporte una vez identificada la infección. No existe tratamiento específico contra el VHD ni vacuna. Se debe controlar y tratar la infección por VHB.

HEPATITIS E

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

Es un virus ARN (antes denominado hepatitis no A no B), de transmisión fecal-oral y se asocia con la eliminación del virus en las heces. Es la causa más frecuente de ictericia y hepatitis aguda en el mundo. Tiene alta prevalencia en zonas con malas condiciones de saneamiento.

PATOGENIA Y CLÍNICA

El VHE parece actuar como virus citopático. El período de incubación es de alrededor de 40 días (intervalo de 15-60 días). La enfermedad clínica que produce el VHE es similar a la del VHA, pero suele ser más grave. No evoluciona a la cronicidad. Además de causar a menudo un cuadro más grave que el del VHA, tiende a afectar a pacientes mayores (con un pico entre los 15 y los 34 años). A la vez, es un patógeno destacado en mujeres embarazadas e inmunosuprimidos, causando IHA con elevada mortalidad. El VHE también puede descompensar una hepatopatía crónica preexistente.

DIAGNÓSTICO

Se han desarrollado anticuerpos frente a las partículas del VHE, además del análisis de anticuerpos IgM e IgG para distinguir entre infecciones agudas y resueltas. Los anticuerpos IgM se positivizan alrededor de la primera semana de enfermedad. Puede detectarse ARN del virus en heces y suero mediante PCR.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento es de sostén una vez detectada la infección. No hay datos que sugieran que la inmunoglobulina sea eficaz en prevención de infecciones.

OTROS VIRUS HEPATOTRÓPOS

EPSTEIN BARR VIRUS

Es un virus ADN bicatenario perteneciente a la familia de virus herpes. Es agente causal de mononucleosis infecciosa (90% de los casos de síndrome mononucleósico). Existen 2 tipos, A y B, de similares características en cuanto a clínica y evolución. Genera una primo infección, que puede ser asintomática o presentar la clínica característica de la mononucleosis, y luego una infección latente que perdura durante toda la

vida. Afecta al 95% de la población mundial en algún momento de la vida. La transmisión es a través de secreciones orales y, en menor medida, relaciones sexuales con penetración. En países en desarrollo, la primo infección ocurre en la lactancia y primera infancia.

CLÍNICA

La infección por EBV presenta un período de incubación de entre 30 y 50 días. En la lactancia y primera infancia, la infección es asintomática. En niños mayores y en la adolescencia, la primo infección se caracteriza por faringitis, astenia y adenopatías generalizadas. Es frecuente que se acompañe de fiebre persistente (de hasta una semana de duración) y esplenomegalia (que puede ser de evolución rápida, causando dolor e hipersensibilidad en hipocondrio izquierdo). En el 10% de los casos de mononucleosis, el cuadro se presenta con hepatomegalia. No es frecuente ver ictericia ni hepatitis sintomática por EBV, pero es común la elevación de las enzimas hepáticas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en las características clínicas del cuadro y en pruebas de serología. El cultivo de virus es tedioso y tarda entre 4 y 6 semanas. Existen pruebas serológicas con búsqueda de anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos (EB, EA, VCA). Un laboratorio que muestre leucocitosis entre 10.000 y 20.000 a predominio linfocítico, con un 20 a 40% de linfocitos atípicos, ayuda a orientar el diagnóstico. Es frecuente encontrar disminución de plaquetas (entre 50.000 y 200.000).

TRATAMIENTO

El tratamiento es fundamentalmente de sostén. Debe indicarse reposo y evitar actividades deportivas por 2-3 semanas (o el tiempo que perdure la esplenomegalia), abundante consumo de líquidos y tratamiento analgésico y anti-térmico con paracetamol o AINES. Los fármacos antivirales disminuyen la carga viral y la replicación, pero no reducen su gravedad ni duración del cuadro. En ciertas situaciones, está indicada la terapia con ciclos (de menos de 2 semanas) de corticoides. Estas situaciones son: dificultad respiratoria, trombocitopenia con hemorragia, anemia hemolítica autoinmune, crisis comiciales y meningitis.

El pronóstico es excelente. Los síntomas principales suelen durar entre 2 y 4 semanas, seguidos de una recuperación gradual a los 2 meses posteriores al inicio de los síntomas.

CITOMEGALOVIRUS

Es un virus ADN bicatenario, perteneciente a la familia de herpes virus, caracterizado por su gran tamaño. Genera infección a través de secreciones orales y genitales, así como también infecciones nosocomiales por trasplante de aloinjertos e infección congénita por transmisión transplacentaria. Los mecanismos fisiopatológicos de la infección no han sido completamente dilucidados. Es sabido que el virus invade todos los tejidos del organismo, sin presentar tropismo por ningún linaje celular en particular.

CLÍNICA

En pacientes inmunocompetentes, suele generar una infección asintomática. En pocos casos, presenta clínica típica de un síndrome mononucleósico, con fatiga y en ocasiones adenopatías cervicales. En pacientes inmunodeprimidos, la sintomatología está relacionada con el grado de inmunodepresión de cada paciente. En pacientes con inmunodepresión leve, se presenta con fiebre, trombocitopenia y disfunción hepatocelular leve. Por otro lado, en pacientes con inmunodepresión intensa, genera una infección diseminada que afecta hígado, pulmones, aparato digestivo y sistema nervioso central.

Con respecto a la infección congénita, esta es sintomática en el 10% de los casos (en menos del 5% la infección es multiorgánica grave). Entre el amplio espectro de síntomas, lo que más frecuentemente se observa es: RCIU, prematuridad, hepatoesplenomegalia, ictericia, petequias y púrpura, microcefalia, coriorretinitis. La secuela más común es alteración de la audición. Las infecciones perinatales son en su mayoría asintomáticas y no dejan secuelas. La hepatomegalia se observa en el 19% de los casos, con aumento de la alanina aminotransferasa (mayor a 80 UI/ml) e hiperbilirrubinemia directa (mayor a 2 mg/dl).

El diagnóstico se basa en la demostración de la primo infección. Las pruebas serológicas no son útiles para demostrar infección actual (un aumento de la IgM indica infección reciente, pero la IgM puede permanecer elevada durante

varios meses). Se puede emplear prueba de PCR con muestras de orina, saliva y sangre, o bien cultivo y tinciones histológicas de las mismas.

TRATAMIENTO

El uso de antivirales en huéspedes inmunodeprimidos disminuye la morbimortalidad, así como la profilaxis en receptores de trasplantes limita el desarrollo de una enfermedad por CMV. Actualmente, se utilizan fármacos antivirales como el Foscarnet y el Ganciclovir.

Comentario de la especialista

Dra. María Lorena Cavalieri

El caso presentado en este capítulo muestra una niña de 10 meses de edad que consulta por un cuadro viral agudo asociado a hepatoesplenomegalia con enzimas hepáticas aumentadas y función hepática conservada. Las hepatitis virales, como se desarrolló anteriormente, son causadas principalmente por virus hepatotrópos, pero existen otros virus que provocan enfermedad extrahepática, causando en algunas ocasiones hepatitis. Para llegar al correcto diagnóstico, es importante realizar un amplio interrogatorio sobre antecedentes personales, familiares, epidemiológicos y exposición a tóxicos, así como también un examen físico completo para evaluar signos de enfermedad hepática crónica.

Dentro de los exámenes complementarios que se realizan, el laboratorio muestra aumento de enzimas hepáticas con valores normales o elevados de bilirrubina, y alteración de la albúmina y coagulograma en los casos graves o con enfermedad hepática subyacente. Para el diagnóstico etiológico se solicitan marcadores serológicos. Una vez descartados los virus hepatotrópos, deben investigarse otros virus no hepatotrópos, y si la clínica o el laboratorio lo sugieren, deben plantearse otros diagnósticos diferenciales como autoinmunidad, enfermedades metabólicas o tóxicos, según el grupo etario del paciente. Otro estudio que ayuda al diagnóstico es la ecografía abdominal que evalúa la morfología del hígado, bazo y vías biliares.

Durante el seguimiento de los pacientes con hepatitis virales, es importante evaluar la mejoría del hepatograma, para detectar los casos de

mala evolución y derivarlos a tiempo al hepatólogo infantil.

El tratamiento de las hepatitis virales agudas es principalmente de sostén. En el caso de las hepatitis crónicas, B y C, es importante que sean derivados al hepatólogo infantil al momento del diagnóstico para evaluación del tratamiento, seguimiento y prevención de las posibles complicaciones.

La mejor prevención es proporcionar alimentos, agua y condiciones sanitarias seguras (hepatitis A y E), vacunación (hepatitis A y B), detección precoz de madres portadoras y control de infecciones en donaciones de sangre (hepatitis B y C).

Bibliografía

- Álvarez F, Ciocca M, Ramonet M. *Hepatología para pediatras: guía práctica para el manejo clínico*. 1º ed. Buenos Aires: Médica Panamericana. 2019.
- Galoppo M, Lezama Elecharri C, Solaegui M, Torres S, et al. *Hepatitis virales en la infancia*. *Rev. Hosp. Niños (B. Aires)* 2016;58(261):73-82.
- Hierro Llanillo L, González de Zárate A. *Hepatitis Crónica. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP*. 2da edición. Madrid. Ergón S.A. 2010. p. 205-209.
- Infante Pina D, Segarra Cantón O. *Hepatopatía Aguda. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP*. 2da edición. Madrid. Ergón S.A. 2010. p. 259-265.
- Mack CL, González-Peralta RP, Gupta N, Leung D, et al. *NASPGHAN Practice Guidelines: Diagnosis and Management of Hepatitis C in Infants, children, and Adolescents*. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2012;54(6):838-55.
- Marugán de Miguelsanz JM, Torres Hinojal MC. *Hepatitis Agudas*. *Pediatr Integral*. 2015;14(3):198-204.
- Murray KF, Shah U, Mohan N, Heller S, et al. *Chronic Hepatitis*. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2008;47:225-233.
- OPS/OMS. *Boletín sobre las Hepatitis Virales en la Argentina N°1*. Año 1. 2019.

*Dra. María Lorena Cavalieri

Médica Pediatra HIGA Eva Perón de San Martín.

Hepatóloga Infantil Hospital Italiano de Buenos Aires

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Hospital Municipal Eva Perón de Merlo. Residencia de Pediatría



Dra. Silvia Torrez

Dra. Inés Ivana Barrero Valdez

Dra. Viviana Lasso

Residentes

Sumario

Acerca de la presentación de una situación clínica de EDA y las reflexiones requeridas para el manejo adecuado de la afección aguda y los desequilibrios hidroelectrolíticos y nutricionales concomitantes.

Situación clínica

Paciente masculino de 1 año 5 meses de edad con antecedentes de 2 internaciones previas, 1 en neonatología para recuperación nutricional por RNT/BPEG, la segunda por causa social. Presenta cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por vómitos persistentes en abundante cantidad, deposiciones líquidas que rebasan el pañal, registro febril no cuantificado, en guardia se constata mucosas secas y pálidas, relleno capilar enlentecido, signo de pliegue +, extremidades frías. Se realiza 2 expansiones con solución fisiológica a 20ml/kg en 30 min cada 1, solicitan laboratorio donde se constata acidosis metabólica con acidemia por lo que pasa a sala de internación para control y tratamiento.

REFLEXIONES:

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Deshidratación severa

Acidosis metabólica con acidemia

Gastroenterocolitis agua

¿Qué se toma en cuenta al momento de realizar el examen físico?

El examen físico deberá ser completo para poder descartar otros posibles focos infecciosos. El dato de mayor relevancia al momento de realizar dicho examen es el estado de hidratación del paciente, para esto es importante conocer el tiempo de evolución, la magnitud de las pérdidas y la cantidad de líquidos administrados y la tolerancia a los mismos, evaluar el estado de conciencia, presencia de sed, características de ojos y de la piel.

¿Qué es importante saber?

Debe considerarse la forma de comienzo, el tiempo de evolución, presencia de otros síntomas y signos, el tipo, número y volumen de las deposiciones, si realizó algún tratamiento (medicación sintomática, antibióticos, ácido acetilsalicílico, tóxicos como infusiones caseras), y cantidad de líquidos aportados. Además es de gran valor diagnóstico las características de las deposiciones, dado que permiten inferir el mecanismo fisiopatológico involucrado y el sitio comprometido.

Definición:

Diarrea es el aumento del número o frecuencia de las deposiciones, con cambios en la consistencia y/o volumen de la materia fecal, con pérdida variable de agua y electrolitos, se dice que

es aguda cuando la duración es menor a 14 días, persistente mayor de 14 días y crónica mayor a 30 días.

Factores de riesgo:

Estos pueden ser:

Ambiental y familiar: consumo de agua y alimentos contaminados, inadecuado manejo de excretas, hacinamiento, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social

Edad: A menor edad mayor riesgo de deshidratación asimismo mayor riesgo de compromiso general por bacteriemia y/o sepsis asociada.

Estado nutricional: La recuperación de la mucosa intestinal es más lenta en pacientes desnutridos por tanto son más susceptibles de presentar diarreas prolongadas

Enfermedades de base: Podrían modificar las conductas terapéuticas (cardiopatías, inmunodeficiencias, etc.).

Tipos de Diarrea:

Acuosas: compromete el intestino delgado, son líquidas, abundantes y llevan a la deshidratación con pérdidas variables de electrolitos, según el mecanismo de acción.

Secretoras: Están mediadas por enterotoxinas que actúan a través del AMP cíclico, estimulando la secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz intestinal (pérdidas importantes de sodio). Entre ellas: *Vibrio cholerae*, *Escherichia coli* enterotoxigénica (ECET), *Shigella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* y *Clostridium perfringens*.

Malabsortivas: causan pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente deposiciones con moco y estrías de sangre. Por ejemplo: *Giardia lamblia*, Rotavirus, *Escherichia coli* enteropatógena (ECEP) y *E. coli* enterohemorrágica (ECEH).

Osmóticas: atraen agua, provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento en la producción de gas.

Las diarreas disintéricas, con invasión y penetración de la mucosa del colon provocan fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas con moco y sangre, acompañadas de cólicos, pujos y tenesmo. Por ejemplo: *Shigella*, *Escherichia coli* enteroinvasiva y raramente *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, *Yersinia enterocolitica* y *Entamoeba histolytica*.

AGENTES MÁS FRECUENTES EN DIARREA AGUDA. DIARREA SIN SANGRE.

Agente	Características	Transmisión
Virales: Rotavirus: Adenovirus:	más frecuentes en: menores de 2 años. más frecuente en niños concurrentes a jardín otoño-invierno	fecal- oral respiratoria
Bacterianas :		
<i>E. coli</i> enterotoxigénica	En todas las edades de AMPc (símil cólera).	Fecal - oral.
<i>E. coli</i> enteroadherente	Relacionada con diarrea aguda, crónica y del viajero.	
<i>E. coli</i> enteropatógena	Relacionada con brotes epidémicos.	
<i>Salmonella</i> no typhi (enteritidis, <i>cholerae</i> suis)	Incubación: 6-72 hs. más en menores de 5 años.	Alimentos contaminados incluyendo huevo crudo.
<i>Salmonella</i> typhi	Esporádica.	Contacto interhumano.
<i>Staphylococcus aureus</i>	Incubación: 1-7 hs. Producida por enterotoxina A a E.	Alimentos contaminados por manipuleo de persona colonizada.
<i>Vibrio cholerae</i>	Endémico en el N.O. argentino.	Agua y alimentos contaminados.
<i>Aeromonas hydrophila</i>	Acción por toxina que aumenta el AMPc.	
Parasitarias		
<i>Giardia lamblia</i>	Incubación: 1-4 semanas. Relacionada con síndrome de mala absorción.	Alimentos y aguas contaminadas. Quistes pueden sobrevivir más de 3 meses.
<i>Cryptosporidium</i>	Incubación: 12-14 días. Autolimitadas (1-20) días.	Persona-persona y aguas contaminadas.
<i>Isospora belli</i> Cs	En inmunocomprometidos, (SIDA).	

DIARREA CON SANGRE:

Agente	Características	Trasmisión
Bacterianas		
E. coli enteroinvasiva	Lactantes y niños.	Agua y alimentos contaminados.
E.coli enterohemorrágica	Productora de verotoxina. Se relaciona con S.U.H.	Alimentos contaminados.
Shigella (flexneri, sonnei, boydii)	Disentería bacilar. Artritis reactivas a las 2-3 semanas. Más frecuente entre 6 meses y 2 años.	Agua y alimentos contaminados. Fecal - oral
Salmonella	Alrededor del 10% de los episodios	Alimentos contaminados.
Campylobacter yeyuni	Período de incubación 1-7 días.	Aves de corral y Aguas contaminadas.
Yersinia	Puede manifestarse como pseudoapendicitis, acompañarse de poliartritis o artralgias, eritema nudoso.	Alimentos contaminados.
Parasitarias Entamoeba histolytica	Incubación 2-4 semanas. Poco frecuente en niños.	Persona a persona Agua y alimentos contaminados.

Diagnóstico

Un niño con diarrea debe ser evaluado a través del interrogatorio y del examen físico

Se debe evaluar:

las características y tiempo de evolución de las deposiciones

Presencia de otros síntomas

Presencia de vómitos

Color y volumen de la orina

Alteraciones del sensorio

Alimentos que recibió

Tratamientos recibidos

Antecedentes de viaje Antecedente de enfermedades previas

Examen Físico:

Estado de hidratación

Semiología abdominal

Estado nutricional

Estado toxoinfeccioso

Además: peso, talla, FC, FR

Tener en cuenta la presencia de:

Moco y sangre

Pujos y tenesmo

Fiebre

Vómitos

Dolor abdominal

La deshidratación es lo que nos da la severidad del cuadro clínico en la diarrea

	Sin deshidratación	Deshidratación leve a moderada	Deshidratación severa
Estado general	Bueno, alerta	Intranquilo, irritable	Letárgico, inconsciente
Ojos	Normal	Hundidos	Muy hundidos y secos
Lágrimas	Presentes	Ausentes	Ausentes
Boca y lengua	Húmeda	Seca	Muy seca
Sed	Normal	Sediento, bebe ávidamente	No poco o es incapaz de beber
Piel	Pliegue: retracción inmediata	Pliegue: se deshace con lentitud.	Pliegue: se deshace muy lentamente: más de 2 segundos.
Pulso	Normal	Más rápido de lo normal.	Muy rápido, fino o no se palpa.
Llenado capilar	Menor de 2 seg.	De 3 a 5 segundos	Mayor de 5 segundos.
% de peso	<5	5 - 10	>10
Déficit estimado del líquidos	<50	50 - 100	>100
Decida	No tiene deshidratación	Si tiene 2 o más síntomas o signos, tiene deshidratación.	Si tiene uno o más de los signos marcados tiene deshidratación grave con shock. Si tiene dos o más de los otros signos pero ninguno marcado tiene deshidratación grave sin shock.
Tratamiento	Plan A	Plan B	Plan C: evaluar con o sin shock

¿Cuándo es necesario solicitar estudios complementarios?

Cuando existe sospecha clínica de alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas graves. En pacientes con clínica de acidosis grave con Hipo o hipernatremia

Los exámenes más usados son:

Laboratorio: hemograma completo, urea, creatinina, estado ácido-base, ionograma, orina completa

Estudio virológico de materia fecal: el resultado no cambia la conducta básica del tratamiento, se realiza por razones epidemiológicas y para determinar etiología en casos de focos de gastroenteritis en niños internados o en jardines maternos o infantiles.

Examen en fresco en materia fecal: Cuando se sospecha parásitos: Giardia Lamblia, Entamoeba Histolytica en zonas endémicas, Criptosporidium en pacientes inmunodeficientes.

Coprocultivo: No se solicita de rutina, debe pedirse antes de iniciar la terapéutica antimicrobiana. Tiene valor epidemiológico en situaciones de brote en áreas geográficas o en instituciones. Se pide según el huésped: En inmunocomprometidos, y en desnutridos graves. En síndromes disintéricos con o sin fiebre, en diarrea sangüinolenta, en deshidratación grave, sepsis y sospecha de Cólera

Tratamiento

El antidiarreico ideal debería ser de administración oral, con potente actividad antisecretora intraluminal, sin efectos secundarios y de bajo costo, pero la mayoría de los fármacos existentes poseen efectos secundarios importantes o tienen actividad antisecretora escasa o nula.

No deben utilizarse en diarrea aguda: Bismuto, carbón, silicatos, anticolinérgicos, difenoxilato, loperamida y probióticos.

TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL (TRO)
Componente esencial en la Atención Primaria.

SRO composición
Cloruro de sodio: 3,5 g. Na ⁺ 90 mmol/l
Cloruro de potasio: 1,5 g. K ⁺ 20 mmol/l
Bicarbonato de sodio: 2,5 g. Cl ⁻ 80 mmol/l
I Glucosa: 20 g. HCO ₃ ⁻ 30 mmol/l
Agua: csp 1000 ml. Dextrosa 111 mmol/l

La composición de la fórmula de sales de hidratación oral (SHO), recomendada por la OMS/ UNICEF, se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda.

Ventajas: barato, fácil de administrar, previene la deshidratación en los estados iniciales del episodio, permite la alimentación precoz y adecuada durante y después de la diarrea, evitando el deterioro nutricional.

PREPARACIÓN Cada sobre debe diluirse en un litro de agua hervida a temperatura ambiente mezclando cuidadosamente antes de ofrecerla. Se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerada.

Plan A: Prevención de la deshidratación, es de manejo ambulatorio.

Madre debe ofrecer más líquidos de lo usual (no té, jugos ni gaseosas), aumentar la frecuencia de la alimentación, ofrecer 10 ml/kg de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida y/o vómitos. Pautas de alarma e higiene

Plan B: Tratamiento en deshidratación leve y moderada.

SRO a 20 ml/kg, cada 20 a 30', hasta lograr la normohidratación, si vomita, espere 10', recomience con pequeñas cantidades. Si tolera seguir con Plan A de lo contrario

Plan C:

Deshidratado grave sin shock.

Requiere internación.

Indicaciones de sonda nasogástrica (SNG): Si vomita más de 4 veces en 1 hora, si no toma la solución, falta de madre o acompañante. Se debe administrar la SHO por gravedad, a 20 ml/kg, cada 20 minutos, con jeringa, si vomita, iniciar gastroclisis a 5 macrogotas/ kg' (15ml/kg/ hora), durante 30 minutos Si tolera: 20 macrogotas/kg' (60 ml/kg/hora)

Fracaso de hidratación oral:

Control inadecuado, empeoramiento de signos clínicos, pérdidas mayores a las aportadas, vómitos incoercibles, distensión abdominal importante, persistencia de signos de deshidratación, luego de 4 a 6 horas.

Contraindicaciones de TRO:

Shock, Ileo, depresión del sensorio, dificultad respiratoria grave, abdomen tenso, doloroso.

Hidratación endovenosa (HE) Está indicada: Deshidratación grave con Shock, contraindicaciones de TRO, fracaso de TRO.

En pacientes con shock: el primer paso será la expansión con solución fisiológica, 20-30 ml/kg de peso, en no más de 30 minutos. Si persisten signos de shock, repetir expansión con igual volumen. El objetivo es aumentar el volumen intravascular y mejorar la perfusión tisular.

En pacientes sin shock o revertido el mismo, se propone continuar con hidratación endovenosa rápida (HER). Es la modalidad de primera elección. Se utiliza solución polielectrolítica

Ventajas Hidratación Endovenosa Rápida (HER): Normohidratación en un breve lapso permitiendo rápida recuperación del paciente, alimentación precoz, con menor costo de internación.

Contraindicaciones de HER:

Menor de un mes, Natremia mayor a 160 mEq/l, pliegue pastoso, Situaciones clínicas especiales, como nefropatías, cardiopatías, síndrome ascítico edematoso Infusión EV continua con solución polielectrolítica a 25 ml/kg/hora (8 macrogotas/kg/minuto), hasta la normohidratación. Dado que aporta no solo K⁺ sino también glucosa y bicarbonato, no es necesario esperar diuresis para su uso.

evaluar: Pasaje inadecuado, Exceso de pérdidas: Por materia fecal, aumentar ritmo de infusión a 35ml/kg/hora. - Poliuria, con glucosuria (+), disminuir el flujo de glucosa, sin glucosuria, evaluar función renal.

Una vez normohidratado el paciente, comenzar con alimentación y reposición de pérdidas concurrentes con SHO a 10 ml/kg después de cada deposición líquida.

SITUACIONES ESPECIALES:

Acidosis metabólica: presente en la deshidratación por diarrea en distinto grado; constante en la grave, con o sin shock. Se corrige fácilmente con la HER. Si existe pH < 7,20 y/o bicarbonato < 10, debe efectuarse corrección rápida con bicarbonato de Na en 1 a 2 hs, con una solución 1/6 molar (1 parte de bicarbonato y 5 partes de glucosado al 5%), según fórmula. $EB \times 0,3 \times kg \text{ de peso} = mEq \text{ de bicarbonato a administrar}$

Deshidratación hipernatrémica: Los estados de hipertoncicidad plasmática producen mecanismos compensadores para evitar la deshidratación celular (osmoles idiógenos). Si en la corrección de la deshidratación, se producen cambios bruscos de la osmolaridad plasmática, éstos osmoles idiógenos atraen agua con producción de edema cerebral y convulsiones. Por ello, en

el tratamiento se debe considerar: a) Reponer el déficit previo en 36-48 horas: corregir el 50% del déficit previo de agua en las primeras 24 horas y el resto en las siguientes 12 a 24 horas. b) Descender la natremia en 10-12 mEq/l, en 24 hs. (0,5 mEq/l/hora): utilizar soluciones a 70 mEq/l de Na⁺ hasta constatar diuresis y luego disminuir la concentración hasta soluciones que contengan 40 mEq/l de Na⁺ y 30 mEq/l de K.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO:

La mayoría de las diarreas acuosas son en su mayoría causadas por virus o bacterias autolimitadas que no requieren antibióticos.

Se deberá indicar la medicación antibiótica en aquellos pacientes internados que:

Presenten un compromiso sistémico que no sea atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas.

En los que se sospecha sepsis o bacteriemias. Además de coprocultivo se les realizarán hemocultivos, urocultivo y eventualmente cultivo de LCR. Se propone un algoritmo orientador para el tratamiento empírico inicial. Se indicará tratamiento en caso de estudio parasitológico positivo: -Para Giardia lamblia: Metronidazol: 15 mg/kg/día en 2 o 3 dosis, durante 7 días, o Tinidazol: 20 mg/kg dosis única durante 3 días. -Para Entamoeba histolytica: Metronidazol 35 a 50 mg/kg/día en 3 dosis durante 7 a 10 días.

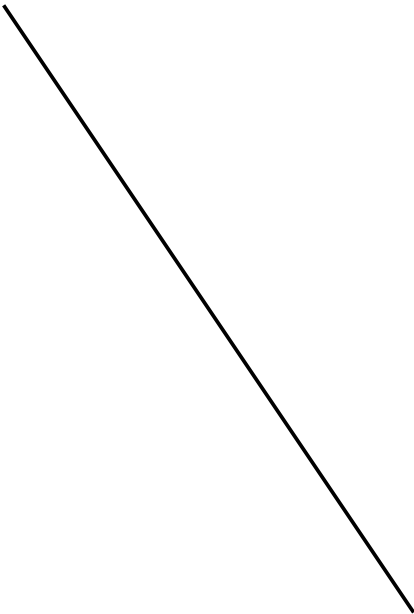
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA

Es importante para la prevención de la diarrea: Educación para la salud y participación de la comunidad en la instalación de medidas de autocuidado como: Alertar sobre los peligros de la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica, asesorar sobre provisión de agua potable y tratamiento de residuos, medidas higiénicas como lavado de manos.

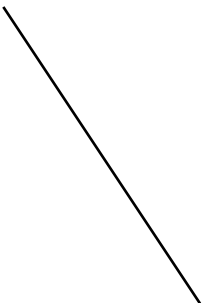
Educación a la comunidad y en especial a las madres acerca de cómo prevenir e identificar precozmente la diarrea, la detección temprana de la deshidratación y otros signos de alarma.

Bibliografía

- Pronap <https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consenso-de-diarreas-agudas-en-la-infancia.pdf>
Setien, C; Reichenbach, J. *Pediatría en Red 2. Afecciones digestivas. Deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas y del estado ácido base.* Pag 329. Ministerio de Salud pcia de Bs As. 2015.



NÚCLEO SITUACIONES CLÍNICAS



Categoría **D**

ABSCESOS SECUNDARIOS A CARIES DENTAL EN PEDIATRÍA

Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de La Vega



Od. Juana Bianchi

Residente de cirugía bucomaxilofacial

Dr. Alejandro Ostrosky

Jefe de servicio

Sumario

La caries es la enfermedad crónica infecciosa más prevalente en el mundo. La atención dental a la infancia debe ser asumida por la salud pública desde el primer año de vida, de forma multidisciplinaria, incluyendo a diferentes profesionales de la salud, dando énfasis a los programas preventivos de salud bucodental. Dejar fuera de la atención bucodental a niños menores de seis años hace que podamos presenciar casos como el que presentamos, con una evolución tórpida, debido a una situación personal de imposibilidad de acceso a un odontólogo.

Introducción

La caries es una enfermedad infecciosa crónica transmisible que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede definir como un proceso patológico, localizado, de origen externo, que se inicia tras la erupción y que determina un reblandecimiento del tejido duro del diente, evolucionando hacia la formación de una cavidad.

La Academia Americana de Odontología Pediátrica define la caries de aparición temprana como la presencia de una o más lesiones (cavidades o no), pérdida (debido a caries) o super-

ficie dentaria obturada en niños de 71 meses o menos de edad.

Respecto a la prevalencia, es la enfermedad crónica infecciosa más prevalente en el mundo. Estudios epidemiológicos en niños españoles indican que un 20% a los tres años, un 40% a los cinco años y un 60% a los 15 años presentan caries.

Las infecciones dentales pueden propagarse a la región vecina, pero también pueden hacerlo por vía hematógena, dando lugar a la propagación de las mismas especialmente en los pacientes médicamente comprometidos.

La infección puede estar restringida al espacio de la pulpa o al área periapical del diente afectado, o bien extenderse al hueso dentoalveolar circundante, así como a los tejidos blandos, provocando celulitis, con el potencial de comprometer la vía aérea. Los abscesos dentales también pueden producirse en los dientes que han erupcionado parcialmente (pericoronaritis).

La celulitis flegmonosa es la inflamación del tejido conjuntivo, especialmente subaponeurótico y subcutáneo que alcanza también los músculos y las aponeurosis. La lesión evoluciona del séptimo al noveno día y se observa un aumento de volumen difuso, depresible en algunas zonas, doloroso a la palpación, con discreto cambio de coloración entre roja y violácea, limitación a la

apertura bucal y con ataque al estado general. Se encuentra una flora microbiana mixta.

Caso clínico

Se presenta al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital de Marino y Luciano de la Vega paciente femenina de 15 años de edad con absceso en región izquierda secundario a foco séptico en pieza dentaria 36.



Se observa piel eritematosa y a la palpación el proceso se encuentra fluctuante en la zona central por lo que se decide realizar drenaje bajo anestesia general.

Primero se identifican los reparos anatómicos y se delimita la extensión de la lesión.



Luego se realiza la antisepsia, colocación de campos estériles, infiltración anestésica, se opta por un abordaje extraoral en región submaxilar izquierda, se divulsionan los tejidos drenando el contenido purulento con la consiguiente colocación de drenaje tubular.



Control a los 10 y 30 días del retiro del drenaje

Discusión

La OMS advierte de las complicaciones potencialmente graves de un diente enfermo. El absceso dental es una complicación de la caries. Las aberturas en el esmalte permiten la llegada de bacterias a la pulpa (pulpitis) y la afectación del hueso alveolar. El absceso alveolar puede evolucionar a un absceso subperióstico y posteriormente producirse una diseminación a los tejidos blandos. En el caso que se presenta anteriormente la infección comienza secundariamente a un foco odontógeno de larga evolución la cual se propaga por los tejidos blandos desencadenando un absceso cervical, por debajo del músculo milohioideo.

Según los autores del libro “Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados” los síntomas de un absceso dental incluyen dolor punzante o palpitante (como latidos). El diente tiene sensibilidad al calor, el frío o la presión. Las encías pueden verse rojas y edematizadas. La paciente tratada refirió haber tenido sintomatología dolorosa de un mes de evolución sin realizarse ningún tratamiento. También recomiendan que el drenaje se presente cerca del diente afectado. Dependiendo de la localización de la pieza afectada, la fístula puede drenar a nivel intra- o extraoral. Alrededor del 80% de las fístulas extraorales de origen dentario se producen por afectación de piezas dentarias del maxilar inferior. Si el afectado es un premolar o molar mandibular, el drenaje se abre a nivel del cuerpo mandibular, de las caras laterales del cuello o región inferior auricular, por esta razón se optó por realizar un drenaje en región cervical izquierda, cerca de la pieza dentaria afectada.

La prevención de la caries en la infancia temprana depende de esfuerzos multidisciplinarios: pediatras, odontopediatras, enfermeros de Pediatría, el Gobierno como responsable de invertir en salud.

Sería conveniente una primera visita al odontólogo el primer año de vida.

En nuestro caso se aconsejó una serie de medidas preventivas con el objetivo de disminuir la prevalencia de caries dental y de sus complicaciones. Para ello las acciones de promoción de la salud están basadas en tres pilares: 1) aplicación de suplementos periódicos de flúor; 2) consejos sobre dieta no cariogénica, y 3) indicaciones sobre la higiene dental adecuada acompañado de

la enseñanza de una buena técnica de cepillado.

Las medidas preventivas implantadas incluyen revisión, educación, radiografía simple diagnóstica, sellado (dentición definitiva), obturación (dentición definitiva), extracción (cualquier edad), aplicación de flúor y atención especial (niños con enfermedades sistémicas, dentición definitiva).

Conclusiones

Este caso nos enseña la importancia de no menospreciar las caries. La prevención y la higiene dental es prioritaria en educación para la salud. El tratamiento debe ser precoz por el pediatra y/o el odontopediatra.

El mantener una adecuada higiene oral disminuye el riesgo de infecciones.

Es de suma importancia eliminar la causa del proceso infeccioso ya que será el éxito del tratamiento además de realizar el drenaje correspondiente. En este caso fue clave realizar la exodoncia del foco odontogénico, de lo contrario el proceso infeccioso recurre al poco tiempo y también complementarlo con una terapia antimicrobiana.

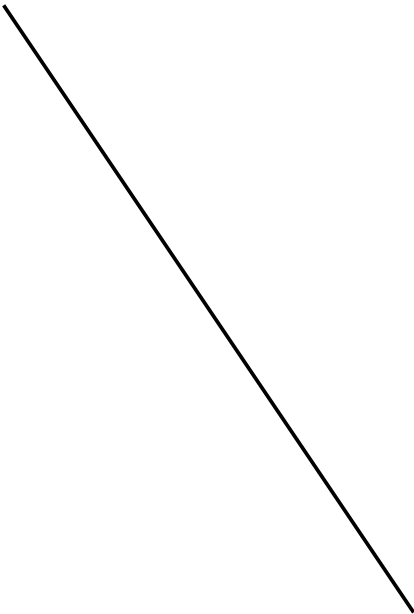
El diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento adecuados y oportunos de cualquier proceso infeccioso evita secuelas posteriores.

Bibliografía

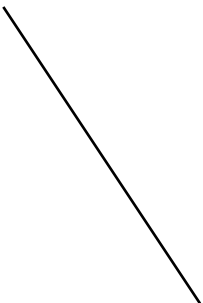
-

Aguilar-Ayala FJ, Duarte-Escobedo CG, Rejón-Pasada ME, Serrano-Pina R, Pinzón-Te AL. Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados. *Acta Pediatr Mex.* 2014;35:254-66. Organización Mundial de la Salud Proyecto de directrices sobre los azúcares.

Organización Mundial de la Salud The objectives of the WHO Global Oral Health Programme (ORH).



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **E**

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría



Dra. Cintia Barrientos

Dra. Soledad Corizzo

Dra. María Florencia González

Residente

Dra. Sofía Riccardi

Residente

Dra. María Cristina Portela

Revisora

Sumario

La piel y las mucosas son asiento preferente de numerosas enfermedades, y pueden alterarse como consecuencia de una gran diversidad de cuadros sistémicos, siendo muchas veces claves para el diagnóstico y tratamiento del proceso de base.

Presentamos una clasificación que agrupa los principales diagnósticos en los que debemos pensar según su frecuencia en aparición.

Situación Clínica.

Paciente de sexo femenino, de 1 año de edad, sin antecedentes heredofamiliares, perinatales, ni personales patológicos de importancia; con historia de cuadro de bronquiolitis de 2 semanas de evolución, que fue tratada en forma ambulatoria. Consulta a la guardia presentando lesiones cutáneas maculares, anulares, con palidez central (aspecto de escarapela) y lesiones purpúricas que confluyen formando placas, diseminadas en cabeza, tórax y extremidades

superiores e inferiores. Presenta edema en miembros inferiores Godet +. Al examen físico se encuentra en buen estado general, eutrófica, afebril, normohidratada, compensada hemodinámicamente.

Laboratorio: hemograma con hemoglobina de 11,5 gr/dL, hematocrito de 35%, leucocitos de 15.000/mm³, neutrófilos de 56%, linfocitos 36%, eosinófilos 1% y plaquetas de 590.000/mm³, velocidad de sedimentación globular 25 mm/hora; ionograma, función renal, glucemia, hepatograma y coagulograma dentro de parámetros normales.

Reflexiones

¿Qué manifestaciones cutáneas deben hacernos pensar en una enfermedad sistémica subyacente?

Discusión

Presentamos el caso de una paciente previa-

mente sana, con antecedente de bronquiolitis de 2 semanas de evolución, que comienza con cuadro caracterizado por lesiones purpúricas en la cara, pabellones auriculares y en extremidades y edema de miembros inferiores, sin compromiso del estado general. La anamnesis y la observación clínica, permitieron descartar diagnósticos diferenciales y arribar al diagnóstico de EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO DEL LACTANTE.

Se interna en Sala de Pediatría, presentando buena evolución, con progresión de lesiones a máculas hiperpigmentadas en el transcurso de 3 semanas.

Comentarios

La piel y las mucosas son asiento preferente de numerosas enfermedades, y pueden alterarse como consecuencia de una gran diversidad de cuadros sistémicos, siendo muchas veces claves para el diagnóstico y tratamiento del proceso de base.

Presentamos una clasificación que agrupa los principales diagnósticos en los que debemos pensar según su frecuencia en aparición.

Clasificación según manifestación cutánea

Dermatitis atópica: conjunto de lesiones cutáneas que aparecen en individuos atópicos, cuyas manifestaciones y localización varía según la edad.

- ✓ Lactante: pápulas o placas eritematosas y edematosas, muchas veces con erosiones, exudación y costras. Comienza alrededor del 5° mes de vida. Se localiza habitualmente en cara respetando zonas periorificiales.
- ✓ Niños: lesiones ecematosas con vesículas que se transforman en erosiones con exudación y formación de costras. Se manifiesta entre los 2 años de vida y la pubertad. Predomina en zonas de flexión (codos y rodillas).

El diagnóstico es clínico, el seguimiento puede realizarlo el pediatra de cabecera, quien debe resaltar la importancia de las medidas de humectación y la prevención de exacerbaciones. La terapéutica tópica con Corticoides de baja potencia (Hidrocortisona 1%) y el alivio del prurito constituyen el tratamiento de elección en los cuadros agudos.



Escabiosis: ectoparasitosis producida por el ácaro *Sarcoptes Scabiei*. Se caracteriza por una erupción pápulo-pustulosa generalizada, que afecta a varios miembros de una familia o comunidad cerrada, muy pruriginosa, sobre todo por las noches. Las zonas afectadas son los espacios interdigitales de las manos, superficies de flexión de muñecas, glúteos, región genital yaréola mamaria. En ocasiones se puede visualizar una elevación lineal de la piel que corresponde al túnel excavado por la hembra del ácaro. El tratamiento debe ser para todos los convivientes, con Permetrina 5% y haciendo hincapié en la decontaminación de los fómites.

Púrpura:

Púrpura de Schönlein-Henoch: vasculitis más frecuente en la infancia, de tipo necrosante, cutáneo-sistémica, que predomina en vasos de pequeño calibre, producida por mecanismos de hipersensibilidad, mediada por IgA1, que afecta la piel, las articulaciones, el tracto gastrointestinal y los riñones. Predomina en varones entre los 5 y los 15 años. Habitualmente presentan antecedente de infección respiratoria alta aunque también fue descrita la asociación con fármacos, inmunizaciones, alimentos, picaduras de insectos y exposición al frío.

A nivel dermatológico se caracteriza por presentar lesiones tipo maculo pápulas que luego se convierten en pápulas urticariformes, pruriginosas y purpúricas. Tienden a distribuirse simétricamente en las extremidades inferiores, con predominancia en las superficies de extensión, aunque también puede afectar a las extre-

midades superiores y la cara. En la mitad de los casos están implicadas las nalgas, siendo esta localización una orientación diagnóstica. En general se presenta con edema en cuero cabelludo, manos y pies y en los niños mayores es frecuente el edema equimótico escrotal.

La clínica también incluye artralgias que pueden ser mono o poli articulares, no deformantes, con dolores migratorios y edema peri articular sin derrame sinovial que no deja secuelas, afectando habitualmente los tobillos y rodillas, menos frecuentemente codos, muñecas y las interfalángicas distales. Puede presentarse dolor gastrointestinal tipo cólico, vómitos, diarrea, melena, hematemesis, hasta cuadros de mayor gravedad como para sugerir abdomen agudo provocado por invaginación intestinal ileocecal y la perforación intestinal. A nivel renal puede encontrarse hematuria transitoria o persistente, proteinuria de grado variable, o síndromes nefrótico o nefrítico. En general, es de carácter leve y autolimitado, sólo una minoría desarrollará una lesión renal permanente o terminal. Es fundamental su cuidadosa detección, por ser el síntoma de mayor gravedad.

Ante la presencia de alteraciones en piel o compromiso orgánico leve, ya sea articular, gastrointestinal o renal, pueden manejarse en forma ambulatoria. De otra forma requerirá internación.

Es una enfermedad auto limitada, cuya resolución tarda generalmente entre 4 y 6 semanas, aunque es posible observar recurrencia de los signos y síntomas después de semanas e incluso de meses. La mayoría de los niños evolucionan favorablemente y no precisan ningún tipo de tratamiento. De ser necesario, el mismo será sintomático, con antiinflamatorios. De ser necesaria la administración de esteroides está indicada en pacientes con síntomas digestivos intensos, cuando existe hemorragia gastrointestinal o, de manera muy infrecuente, afectación significativa de algunos órganos (por ejemplo, los testículos) y enfermedad renal grave.

El pronóstico se limita al riesgo de enfermedad renal, por lo cual el seguimiento se orienta al diagnóstico temprano de esta, cuyo riesgo se extiende hasta un año desde el inicio de la enfermedad, con análisis de orina, inicialmente en forma semanal, luego quincenal, mensual y trimestral.

Edema agudo hemorrágico del lactante:

variante benigna de vasculitis leucocitoclástica de vasos pequeños, que afecta casi exclusivamente a niños menores de 24 meses que han pasado una infección reciente, habitualmente de vías respiratorias.

Se observan lesiones cutáneas purpúricas grandes y edema. Estas lesiones son dolorosas y se localizan en la cabeza y en la parte distal de las extremidades, respetando generalmente el tronco. Ocasionalmente puede presentarse con edema facial, necrosis o ampollas. Es característico de esta enfermedad el amplio contraste entre las manifestaciones cutáneas y el buen estado general del paciente.

El diagnóstico es clínico, sin ser necesario solicitar estudios complementarios. Dado que se trata de una enfermedad auto resolutive, de curso benigno, el tratamiento utilizado consta en medidas de soporte como AINES en caso de dolor y reposo. La mayoría de los pacientes se recuperan en 3-6 semanas, aunque un 30-40% recaerá durante los primeros doce meses y un 10 % de forma tardía.

Vasculitis infecciosas: a pesar de que habitualmente se presentan en el contexto de una infección viral banal, no podemos desestimar el cuadro por la gravedad que implica esta presentación en el contexto de una infección por *Neisseria Meningitidis*.

Meningocóccemia: existe un amplio rango de manifestaciones clínicas de la enfermedad producida por *Neisseria Meningitidis*, variando desde el paciente portador nasofaríngeo benigno, bacteriemia sin sepsis, meningococemia fulminante sin meningitis, meningitis con o sin meningococemia y meningococemia crónica.

Los serogrupos A y C son los principales causantes de epidemias, mientras que el serogrupo B se observa en casos esporádicos.

Se presenta con cuadro clínico caracterizado por fiebre, bacteriemia, con compromiso del estado general, pudiendo ser una enfermedad fulminante. A nivel dermatológico se observan lesiones petequiales de 1-2 mm (pródromo), afecta mucosas (ej conjuntiva palpebral), tronco, miembros inferiores, se agrupan en sitios de ajuste de ropa.

Es fundamental el diagnóstico oportuno para instaurar un tratamiento temprano del shock

asociado a la meningococemia, debido a que consiste en una enfermedad potencialmente fatal. Ante la sospecha se debe aplicar una dosis de Ceftriaxona 100 mg/kg/día. Es preciso realizar quimioprofilaxis del caso índice y los contactos con Rifampicina durante 48 horas a 10 mg/kg/día en los menores de 1 mes y 20 mg/kg/día en los niños mayores.

Hiperpigmentación:

Neurofibromatosis: enfermedad genética autosómica dominante. Presenta 2 tipos:

Tipo 1: caracterizada por presentar máculas café con leche en piel, con un borde bien definido, de forma redondeada, oval o fusiforme y tamaño variable, habitualmente generalizadas, que aparecen antes de los 4 años de edad y aumentan de tamaño y en número con el desarrollo, generalmente en la primera década de la vida; y neurofibromas, tumores benignos derivados del nervio periférico y sus envolturas.

El diagnóstico se basa en el cumplimiento de dos o más de los criterios de consenso de National Institutes of Health (NIH)

1- Seis o más manchas café con leche mayores de 5 mm en pacientes prepuberales y mayores de 15 mm en pacientes postpuberales.

2- Dos o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme.

3- Signo de Crowe (efélides axilares o inguinales).

4- Glioma de nervio óptico.

5- Dos o más nódulos de Lisch.

6- Lesiones óseas típicas (displasia del esfenoides, displasia o adelgazamiento cortical de huesos largos).

7- Antecedentes de Neurofibromatosis tipo I en padres o hermanos.

Es necesario un seguimiento prolongado de los pacientes que cumplan el primer criterio, puesto que la mayoría acabarán desarrollando otras manifestaciones de NF1.

Tipo 2: más infrecuente. Se asocia a schwannomas bilaterales del nervio acústico.

Enfermedad de Addison: insuficiencia suprarrenal primaria que resulta en una producción insuficiente de gluco y mineralocorticoides y una elevación secundaria de la ACTH y de la actividad de renina plasmática. Los signos y síntomas suelen manifestarse de forma gradual

pero a veces se manifiestan de forma aguda en situaciones de estrés (crisis suprarrenal), lo cual representa una emergencia vital. A nivel de piel podemos encontrar: hiperpigmentación en zonas cubiertas, como genitales, zonas de presión, surcos palmares y mucosa bucal; disminución del vello axilar y pubiano; calcificación del pabellón auricular. Se puede asociar a vitíligo.

Síndrome de Cushing: conjunto de trastornos clínicos causados por un aumento crónico de las concentraciones sanguíneas de cortisol. Los signos y síntomas típicos son cara de luna llena, giba de búfalo, alopecia tipo androgénica, estrías atróficas, distribución irregular de la grasa subcutánea, fragilidad vascular y acné, sin embargo no son síntomas frecuentes en niños, en quienes debemos sospechar este diagnóstico ante pacientes obesos que presenten un entecimiento de la velocidad de crecimiento.

Hipopigmentación:

Esclerosis tuberosa: síndrome neurocutáneo autosómico dominante que se caracteriza por el desarrollo de múltiples hamartomas en distintas localizaciones. Afecta el cerebro, la retina, la piel, el riñón, el corazón y los pulmones. El diagnóstico es clínico, presenta criterios mayores y menores.

Criterios mayores

- ✓ Angiofibromas faciales/placa fibrosa
- ✓ Placas de Shagreen
- ✓ 3 o más manchas hipopigmentadas
- ✓ Fibromas periungueales o ungueales
- ✓ Linfangiomatosis
- ✓ Angiomiolipoma renal
- ✓ Rabdiomioma cardíaco
- ✓ Hamartomas nodulares múltiples retinales
- ✓ Tuberomas corticales
- ✓ Nódulos subependimarios
- ✓ Astrocitoma de células gigantes subependimarios

Criterios menores

- ✓ Lesiones cutáneas en “confeti”
- ✓ Fibromas gingivales
- ✓ Lesiones del esmalte dentario
- ✓ Pólipos rectales hamartomatosos
- ✓ Quistes renales múltiples
- ✓ Hamartomas no renales

- ✓ Quistes óseos
- ✓ Hamartoma retiniano
- ✓ Líneas de migración radiales de la sustancia blanca

Esclerosis tuberosa definitiva: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 criterios menores.

Esclerosis tuberosa probable: 1 criterio mayor y 1 criterio menor.

Esclerosis tuberosa posible: 1 criterio mayor o 2 criterios menores.

Las placas hipomelanóticas pueden presentarse de tamaño mediano o grande (hojas de Fresno) desde 2 o 3 hasta más de 40 de distribución asimétrica o de tamaño confeti múltiples de distribución simétrica que suelen asentar sobre extremidades.

Los angiofibromas faciales son lesiones papulosas o nodulares, rojas o rosadas, de superficie lisa, que se distribuyen de manera simétrica en la cara, en los pliegues nasolabiales y mejillas. Las placas “shagreen” suelen localizarse en el dorso, en el área lumbosacra. Son lesiones sobre elevadas de color anaranjado de superficie rugosa y con aspecto de piel de naranja. La placa fibrosa de la frente es una placa color amarillo amarronado sobre el cuero cabelludo, en la zona frontal. Los fibromas periungueales (tumores de Koenen) son nódulos rojizos o de color piel que aparecen sobre el lecho ungueal.

Vitíligo: enfermedad autoinmune adquirida que resulta en la destrucción de los melanocitos epidérmicos dejando como resultado zonas hipocrómicas o acrómicas en piel y mucosas. Puede presentarse de forma unilateral (asimétrico o segmentario) que es la forma más frecuente y afecta un dermatoma total o parcialmente, o seguir las líneas de Blaschko; o bilateral (vulgar, generalizado o simétrico) que afecta diferentes zonas anatómicas, cara y extremidades distales. El tratamiento se realiza con corticoides tópicos de baja a mediana potencia asociados a inhibidores de la calcineurina (tacrolimus); calcipotriol, laser.

Albinismo: grupo de alteraciones pigmentarias hereditarias. Casi todas las formas son autosómica recesivas. Es consecuencia de un defecto en el enzima tirosinasa con una alteración en la síntesis o almacenamiento de la melanina en los melanosomas. Presenta hipopigmenta-

ción cutánea y alteraciones oftalmológicas.

Fenilcetonuria: error congénito del metabolismo de herencia autosómica recesiva. Las mutaciones del gen, generan deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Las diferentes cantidades de fenilalanina en sangre se traducen en un espectro amplio de manifestaciones clínicas que incluyen retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual, convulsiones, rasgos autistas y comportamiento agresivo en los casos más graves. El diagnóstico temprano a través de los programas de tamizaje neonatal se considera prioritario pues las intervenciones oportunas evitan el daño del sistema nervioso central. A nivel cutáneo se presenta eczema, los pacientes suelen tener ojos azules y cabello claro debido a la inhibición de la enzima tirosinasa, responsable de la producción de melanina, pero estas características no son específicas pues con los años el cabello tiende a tomar un color oscuro, suelen tener un olor a “ratón” debido a la excreción de ácido fenilacético.

Fotosensibilidad:

Dermatomiositis: enfermedad inflamatoria autoinmune multisistémica que se presenta más frecuentemente entre los 4 y 10 años; con predominio en mujeres. El comienzo es insidioso, las manifestaciones clínicas más destacadas son pérdida de peso, cansancio, fiebre, debilidad muscular simétrica de predominio proximal, afección de la musculatura faríngea e hipofaríngea, dolor a la palpación en áreas musculares y múltiples manifestaciones en piel, con lesiones fotosensibles características. En el rostro se presenta con un edema eritematoso violáceo peripalpebral (heliotropo) que puede extenderse al resto de la cara y acompañarse de edema facial, con límites menos definidos a diferencia del lupus, exantema macular fotosensible eritematoso o violáceo en zona superior de tórax, hombros que puede generalizarse (signo de escote en V). Sobre la cara extensora de las articulaciones (metacarpofalangicas e interfalángicas) o en sitios de roce, pueden presentar pápulas aplanadas de color violáceo, muchas veces con descamación (pápulas de Gottron). Estas lesiones con el tiempo se vuelven atróficas. Otras manifestaciones que se observan son calcificaciones en piel o tejido celular subcutáneo, do-

lor abdominal, hemorragia digestiva, afectación pulmonar con debilidad muscular respiratoria, neumonías aspirativas. Es muy rara la asociación con neoplasias. El diagnóstico se realiza a partir de los criterios de Bohan y Peter 1975:

- ✓ Afectación muscular: debilidad muscular simétrica proximal
- ✓ Elevación de enzimas musculares: una o más (CPK, Aldolasa, GOT, GPT, LDH)
- ✓ EMG: hallazgos de miopatía, irritabilidad de inserción
- ✓ Biopsia muscular: signos de necrosis e inflamación
- ✓ Afectación cutánea: eritema heliotropo, pápulas de Gottron

Diagnóstico definido: 3 o 4 criterios + afectación cutánea.

Diagnóstico probable: 2 criterios + afectación cutánea.

Diagnóstico posible: 1 criterio + afectación cutánea.

Los exámenes usuales para apoyar el diagnóstico son enzimas hepáticas y musculares (CPK, GOT, GPT, aldolasa, LDH). Deben medirse las cuatro enzimas, porque hay casos que cursan con elevación de una sola de ellas, reactantes de fase aguda, estudio inmunológico, electromiografía, RM de masas musculares proximales y biopsia muscular. Los objetivos del tratamiento son preservar y mejorar la función muscular, prevenir la atrofia por desuso y evitar contracturas musculares. Su inicio precoz y enérgico se asocia a mejor pronóstico. El pilar del tratamiento farmacológico son los corticoides a altas dosis en su fase de ataque. Si no hay respuesta se recurre a los inmunosupresores (metotrexato y ciclosporina A). Son importantes la terapia física y la rehabilitación. Para la afectación cutánea fotosensible, se usa hidroxicloroquina, protección solar, suplemento de calcio y vitamina D.

Lupus eritematoso: enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune. Se presuponen tres factores predisponentes: genéticos, influencia estrogénica y factores ambientales (rayos UV, ciertos medicamentos, las infecciones y el estrés). Se puede dividir en lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso discoide (muy poco frecuente en la infancia) y lupus eritematoso subagudo (se diagnostican en menores de 16 años).

En los niños la forma más frecuente es el lupus eritematoso sistémico, se presenta entre los 10 y los 12 años, raro antes de los 5 años, con preferencia del sexo femenino. Las manifestaciones cutáneas son especialmente importantes, pues aparecen muy frecuentemente en el 80% de los casos: el rash malar, un eritema en alas de mariposa sobre dorso nasal y mejillas con distribución en zonas fotoexpuestas muy características seguidas de lesiones de tipo lupus discoide. Las lesiones individuales son placas bien circunscriptas, eritematosas y con una escama adherente en forma de "tachuela de zapatero" que al desprenderse, genera dolor y puede sangrar. Las cutáneas inespecíficas pueden presentar úlceras orales y vasculitis con expresión clínica de petequias, púrpura palpable, urticaria o fenómeno de Raynaud. Los pacientes pediátricos con LES también pueden padecer artritis, nefritis, pleuritis, alteraciones hematológicas, cardíacas que se incluyen dentro de los criterios diagnósticos:

- ✓ Eritema malar
- ✓ Lesión discoide
- ✓ Fotosensibilidad
- ✓ Úlceras orales
- ✓ Artritis
- ✓ Serositis
- ✓ Alteraciones hematológicas
- ✓ Alteraciones renales
- ✓ Alteraciones neurológicas
- ✓ Alteraciones inmunológicas
- ✓ Anticuerpos antinucleares

El diagnóstico se basa en la presencia simultánea o secuencial de 4 o más de los 11 criterios diagnósticos. Se solicitan exámenes de laboratorio inmunológicos (FAN, anti DNA, complemento), evaluación de función renal, cardiológica y oftalmológica. El tratamiento requiere de abordaje multidisciplinario, son de gran importancia las medidas orientadas a evitar la fotoexposición, el tratamiento tópico con corticoides y Tacrolimus y también el uso de corticoides sistémicos y los inmunomoduladores que serán resorte del especialista.

Erosión y úlceras:

Aftosis/síndrome de Behçet:

La presencia de aftas se asocia a afecciones gastrointestinales (enfermedad celíaca, rec-

toocolitis ulcerohemorrágica y enfermedad de Crohn), déficits nutricionales (hierro, folatos, vitaminas, zinc), trastornos inmunitarios (HIV, neutropenias).

La enfermedad de Behçet es una afección inflamatoria crónica y recidivante cuya manifestación es una aftosis bipolar recidivante, que se manifiesta como ulceraciones mucosas, dolorosas, que en general se observan en boca y menos usual, en región genital. El tratamiento es sintomático (anestésicos, corticoides locales, sucralfato). En casos graves se puede asociar a Talidomida.

Pioderma gangrenoso: dermatosis neutrofílica que se manifiesta como úlceras cutáneas dolorosas, habitualmente asociado a enfermedad sistémica de base como enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos mieloproliferativos y artropatías. Progresas en pocos días desde una pequeña pústula hasta formar una gran úlcera. El tratamiento se basa en el control de la enfermedad de base.

Exantema:

Exantemas morbiliformes: los exantemas de la infancia son erupciones cutáneas localizadas o generalizadas que pueden ser causados por virus, bacterias, medicamentos o estar asociados con enfermedades sistémicas. Se denomina morbiliforme al que es similar al sarampión (maculopapular), el cual describimos a continuación las características principales debido al alerta epidemiológico en nuestro país por nuevos casos no autóctonos pero con circulación viral en el años 2018-2019. Presentan riesgo de contraerlo niños preescolares no vacunados y adolescentes en quienes falló la vacunación. El pródromo se presenta de 7 a 11 días luego de la exposición con el “triple catarro” y fiebre, el exantema patognomónico, llamado manchas de Koplik, como pápulas puntiformes de color blanco-grisáceo y eritematosas distribuidas en la mucosa yugal. El exantema aparece en el día 14 después de la exposición, es cefalocaudal; se inicia en la cara y luego se disemina al tronco y a las extremidades. Se caracteriza por ser morbiliforme con manchas y pápulas eritematosas que confluyen y desaparecen en el mismo orden que han aparecido. Dejan manchas de color café y descamación. El diagnóstico es clínico y serológico, mediante determinación del título de IgM específica luego de 72 horas.

Exantema escarlatiniforme: erupción eritematosa difusa que resulta de la presencia de exotoxinas pirogénicas producidas por el *Streptococcus pyogenes*, comúnmente en el contexto de una faringitis. Habitualmente afecta a niños de entre 4 y 8 años de edad. El cuadro se presenta de forma abrupta con fiebre asociada a una faringoamigdalitis dolorosa seguida de exantema tras uno o dos días. El exantema caracteriza al período de estado; aparece en la base del cuello, cara y parte superior de tronco, y luego se generaliza. Las numerosas pápulas rojas puntiformes le dan a la piel una textura tipo papel de lija. El enrojecimiento es más pronunciado en los pliegues donde se producen las llamadas Líneas de Pastia, por ruptura de capilares generando líneas de petequias. El diagnóstico es clínico a través de la presentación característica. El diagnóstico diferencial principal debe hacerse con enfermedad de Kawasaki. El tratamiento es el indicado para la faringoamigdalitis estreptococcica.

Enfermedad de Kawasaki: vasculitis que afecta a los vasos de mediano calibre. La etiología sigue siendo desconocida. Se presenta frecuentemente en menores de 5 años. En general, hay una historia previa de cuadro infección viral. El comienzo se caracteriza por fiebre alta, mayor de 39° con una duración mayor a 5 días y puede ser persistente, conjuntamente con ella o a los pocos días aparece la erupción cutánea: exantema polimorfo confluyente y no vesiculoso, los más común es la erupción maculopapular difusa inespecífica, en otras ocasiones exantema urticariano, escarlatiniforme, purpúrico, eritrodermico, y rara vez erupción fina micropustular (zonas de extensión). Compromete tronco abdomen y extremidades, se acentúa en región perineal donde ocurre descamación temprana. Se acompaña de marcada inyección conjuntival bilateral, lengua aframbuesada, labios eritematosos, con sequedad y fisuras, sangrado espontáneo. Además se observa edema en manos y pies y puede evidenciarse linfadenopatía unilateral. Dado que esta enfermedad es multisistémica un diagnóstico temprano es esencial, para evitar las complicaciones en especial las cardíacas que marca el pronóstico de la enfermedad; puede presentarse con compromiso coronario (dilataciones, aneurismas e infarto de miocardio) y arterias periféricas. El diagnóstico de la

enfermedad es clínico y se basa en la exclusión de otras patologías que pueden tener un cuadro similar. A todo paciente sospechado de enfermedad de Kawasaki debe realizarse ecocardiograma bidimensional (diámetro de arterias coronarias menor a 3 mm). El tratamiento consiste en administrar gammaglobulina endovenosa en una dosis única de 2 gr/kg de peso en la fase aguda de la enfermedad. A esto se agrega ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatoria.

Síndrome de shock toxico: se debe a infecciones por cepas *Stafilococo aureus*, productoras de toxinas como superantígenos y también en forma esporádica por *Streptococo pyogenes*. Se manifiesta por la presencia de exantema, afectación multisistémica e inestabilidad hemodinámica. Aparición abrupta de fiebre alta, síntomas generales y la afectación dermatológica. En las primeras 72 hs se desarrolla un exantema escarlatiniforme rojo macular difuso que se acentúa en las áreas de flexión, y habitualmente se desvanece. Entre los 10 y los 20 días de evolución la piel se despega, particularmente entre los dedos, las palmas y las plantas. Los criterios diagnósticos son: fiebre alta, hipotensión, exantema macular difuso (con descamación posterior) y afectación de tres o más de los siguientes órganos: hígado, sangre, riñón, membranas mucosas, tracto gastrointestinal, músculo, SNC. El tratamiento se basa en control hemodinámico (en muchos casos ingreso a UTIP), administración de antibióticos específicos y de ser necesario desbridamiento quirúrgico si existiera foco evidente.

Eritemato-costrosas:

Psoriasis: enfermedad cutánea hereditaria eritematodescamativa caracterizada por lesiones bien definidas con escamas típicas blanco-nacaradas. El rascado de las escamas a lugar a pequeñas lesiones puntiformes sangrantes (signos de Auspitz). Su inicio suele ser posterior a la pubertad. La distribución es generalizada, pudiendo aparecer lesiones ante traumatismos o irritación de la piel. El diagnóstico es clínico pudiendo confirmarse con biopsia de piel. Los tratamientos tópicos incluyen corticoides, antralina, calcipotriol y fototerapia. Los fármacos inmunomoduladores como el metotrexate y la ciclosporina se utilizan en cuadros graves.

Acantosis nigricans: signo cutáneo de resistencia a la insulina que se manifiesta como engrosamiento y oscurecimiento de la piel en regiones de pliegue (axilas, cuello e ingle). Los pacientes que presentan este signo tienen mayor riesgo de contraer DBT tipo 2. En algunos casos puede ser signo de advertencia de tumor maligno en un órgano interno como estómago o hígado.

Dermatitis seborreica: Placas eritematosas de tinte rosado con bordes bien definidos, aisladas o confluentes, que se cubren de una descamación amarillenta de aspecto grasiento. Afecta cuero cabelludo, frente, pabellones auriculares, cejas, pliegues retroauriculares y nasogenianos, párpados y cuello y se puede extender hasta tronco. En las lesiones del cuero cabelludo, se precisa la disolución del componente costroso o queratósico. Esto puede conseguirse con la aplicación tópica de agentes oleosos como aceite de oliva. Tras la aplicación de estos productos durante 1 ó 2 horas, se procede a retirar manualmente las escamas reblandecidas. Posteriormente, tras eliminar las escamas, se puede aplicar una crema de corticoide de mediana potencia. En casos muy generalizados, se puede utilizar un corticoide por vía oral, a dosis de 0,5 mg/kg/día de Prednisona.

Paniculitis:

Eritema nodoso: presencia de lesiones nodulares infiltrativas en piel y tejido celular subcutáneo que se instauran de forma súbita, son dolorosos y calientes, de forma redondeada, bordes irregulares, de 1-5 mm y adheridos a la piel. Se localizan de forma simétrica bilateral principalmente en zona pretibial. Evolucionan en 1-6 semanas como una contusión rojo vinosa y cura sin ulceración ni dejar cicatriz. Las causas pueden ser múltiples, existiendo una estrecha relación con TBC. El tratamiento es reposo y elevación de MMII, AINES y el tratamiento de la enfermedad subyacente.

Bibliografía

Araujo-Vilar David, Barreiro Jesús, Sanchez Iglesias Sofía, Guillán-Amarelle Cristina. *Acantosis nigricans en los síndromes de resistencia grave a la insulina*.
Caixeta, M. F., Lima, J. S., Cunali, V. C. A., & dos Santos, V. D. S. (2017).

Edema agudo hemorrágico da infância: relato de caso e comparação com meningococemia. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, 5(1), 80-86.

Consuegra-Solano, J., Agualimpia-Palacios, L. C., Cadavid-Zapata, K. L., Kury-Palacios, S. Y., & Sánchez, I. P. (2017). Edema agudo hemorrágico de la infancia. *CES Medicina, 31(2)*, 192-198.

E. Fonseca Capdevila, R.M. Fernández Torres, M. Mazaira Fernández. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas en Pediatría. *Pediatr Integral 2016; XX (3): 194-202*

Emerich, P., Neves, A., Machado, I., Fagundes, S., & Almeida, P. (2005). Edema agudo hemorrágico de la infancia. *DermatolPediatri-Lat, 3(3)*, 234-8.

Ferrándiz-Pulido Carla y García-Patos Briones Vicente. Pioderma gangrenoso. Diagnóstico y tratamiento. Servicio de dermatología. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Artículo 203.622

Fonseca Capdevilla E. Dermatitis atópica. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. AEP. 2007.

Galán Gómez E. Neurofibromatosis Tipo 1.

García-Patos Briones V. Escabiosis. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. AEP. 2007.

Olmos Jiménez M.J. y cols. Enfermedad de Cushing en la infancia con presentación atípica. *Anales de pediatría. Vol 76 Num 5. 2014*

Parent D. Vaillant L. Aftas, aftosis, enfermedad de Behcet

Puig Sanz L. Síndromes neurocutáneos. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. AEP. 2007.

Rica I, Grau Vela A. Insuficiencia suprarrenal. *Protoc diagn ter pediatri. 2011;1:166-76*

Royo Gómez M. Enfermedad de Addison. Formas de presentación en pediatría. *Anales de pediatría. Volumen 78, Issue 6, June 2013, Pages 405-408*

Valencia-Herrera, A. M., Morales-Fuentes, R. A., Mejía-Rodríguez, S. A., Álvarez-Reyes, A., Moguel-Parra, G., Escobar-Sánchez, A., & Mena-Cedillos, C. A. (2009). Edema agudo hemorrágico de la infancia en una niña mayor; una entidad diferente de la púrpura de Henoch-Shönlein. *Boletín médico del Hospital Infantil de México, 66(5)*, 440-445.

Vidal Olmo I, Vicente Vila A. Psoriasis. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. AEP. 2007.

***Dra. María Cristina Portela** Revisora
Pediatra/Dermatóloga Infantil

DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA

Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte.

Residencia de Clínica Pediátrica



Dra. Pamela Ecos Fernández

Dra. Luciana Ourracariet

Dr. Juan Esteban Arredondo Rincón

Dra. Mariela Iori

Dra. Valeria Blois

Dr. Alejandro Cruz Carozzo

Dra. Julieta Cortesini Leavi

Dra. Marisa Segovia

Dra. Laura Cuellar Niko

Dra. Florencia Amigo

Dra. Fabiola Rojas

Dra. Geanella Chico Vergara

Residentes

Dra. María Cecilia Carozzo

Instructora de Residentes

Dr. Alejandro Giamello

Revisor

Sumario

La displasia del desarrollo de la cadera es la alteración en la relación entre el cotilo y la cabeza femoral. Presenta una incidencia de 1,5/1000 recién nacidos, siendo más frecuente en las niñas, con una relación 8:1.

La afectación puede ser uni o bilateral, pero existe mayor porcentaje de esta patología en la cadera izquierda.

El término displasia del desarrollo de la cadera hace referencia a un amplio espectro de alteraciones patológicas (luxación, subluxación y displasia) que pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha.

Situación clínica

Martina de 3 meses, concurre al Centro de Salud de su barrio, para realizar su primer control de salud (su madre no pudo asistir a los controles previos).

Se trata de una niña nacida de término, por cesárea (debido a presentación podálica) y con

peso adecuado para la edad gestacional. Recibió alta conjunta y presenta examen físico del recién nacido normal. Antecedente de displasia de caderas en la familia: madre con displasia de cadera tratada con Arnés de Pavlik durante tres meses.

Al examen físico se encuentra en buen estado general, peso y talla dentro de los percentiles normales para la edad. A la exploración presenta una limitación a la abducción en su cadera izquierda y signos de Barlow y Ortolani positivos.

Se solicita una Ecografía de caderas, que informa una cadera izquierda con un ángulo α de 51°.

Reflexiones

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

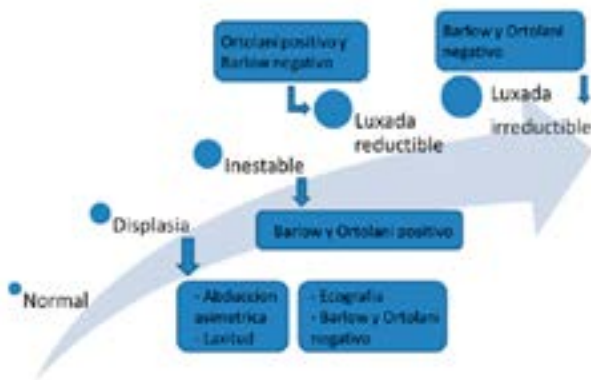
Ante maniobras semiológicas positivas en la exploración de caderas, se sospecha Displasia del Desarrollo de Caderas, patología que se confirma a través de la ecografía.

Se deriva al especialista en Ortopedia y Traumatología, quien decide realizar tratamiento con Arnés de Pavlick, el cual produce una ab-

ducción de la cadera manteniendo la congruencia articular. Realizó el tratamiento durante tres meses, hasta que el ángulo α fue normal, con valoración clínica al mes e imágenes de control a los 2 meses.

Cuando se normalizan los parámetros clínicos y radiológicos comienza el retiro progresivo de la férula de abducción, período que abarca 2 meses aproximadamente. Luego se deben realizar controles periódicos cada 2 a 6 meses, hasta los 4 años de edad, momento en el que se determina radiográficamente la cobertura completa de la cabeza del fémur.

Introducción



Existen tres tipos de displasia de cadera:

- ✓ Displasia teratológica: La cadera luxable de tipo fetal. Está causada por una detención parcial del crecimiento intrauterino en la región de la cadera. Se debe realizar sistemáticamente la exploración de caderas hasta los 6 meses. Siempre son irreducibles y frecuentemente están asociadas a síndromes como la artrogriposis, mielomeningocele y el síndrome de Larsen.
- ✓ Displasia del desarrollo de la cadera: Se produce durante la vida perinatal, no suele asociarse a síndromes y habitualmente tiene factores de riesgo asociados. Si desde el nacimiento la exploración es normal y posteriormente presenta una luxación, se denomina displasia evolutiva o del desarrollo de la cadera.
- ✓ Displasia infantil y/o del adolescente: Se produce cuando existe una deformidad del fémur proximal y/o del acetábulo, pero la articulación en principio está reducida.

Factores predisponentes de deformidad luxante de caderas:

- Historia familiar
- Sexo femenino
- Presentación podálica
- Cesárea
- Madre primípara
- Relacionada con otras malformaciones: Torticolis, deformidades del pie (pie talo, pie varoequino), hiperextensión de rodillas.
- Oligohidramnios
- Peso >4,000 gr

Causas

- Genéticas: 33%. Presenta una probabilidad de luxación 10 veces superior al habitual en el segundo hijo. Es poligénica.
- Hormonales: relacionada a estrógenos y aumento de relaxina, lo que provoca aumento de la laxitud ligamentosa. Predomina en sexo femenino: relación 8/1.
- Mecánicas: Presentación podálica.

Diagnóstico

- Manifestaciones clínicas
- Resalto o click (maniobra Barlow y Ortolani +) hasta los 4 meses
- Asimetría de los pliegues inguinales y glúteos
- Rotación externa del miembro inferior
- Signo de Allis o Galeazzi
- Limitación de la abducción
- Limitación de la movilidad general de la cadera para pacientes mayores a 1 año
- Signo de Trendelenburg en mayores de 3 años

Una adecuada exploración clínica es esencial para realizar un diagnóstico precoz.

Colocado el niño en decúbito supino, se doblan las rodillas en ángulo recto y se abarca el fémur con la mano, logrando que el pulgar quede sobre la cara interna del muslo y los otros cuatro dedos toquen el trocánter mayor. Haciendo palanca sobre el trocánter, se separan las rodillas, de esta manera se introduce la cabeza en el cotilo y se nota el chasquido que la reducción produce. Al realizar la maniobra a la inversa y reproducir la luxación, se nota el chasquido de salida.

La maniobra de Ortolani se realiza con ambas

caderas en flexión y abducción de 90°. Si la cadera está luxada, la abducción está limitada y es la presión de los dedos sobre el trocánter la que reducirá la cadera. Esta maniobra se negativiza en las 48-72 hs en la mayoría de los neonatos, por lo cual ante la persistencia de la positividad de esta maniobra, se debe realizar una valoración inmediata por un especialista en Ortopedia infantil y un tratamiento precoz.

En la cadera luxada también es relevante el acortamiento del miembro, la asimetría de los pliegues cutáneos posteriores y la limitación de la abducción.

La maniobra de Barlow se realiza en la misma posición que la maniobra anterior, partiendo de la cadera aducida y flexionada, se intenta realizar aducción ejerciendo presión simultáneamente sobre las rodillas, en dirección posterior. En este caso se percibe un chasquido cuando la cabeza femoral abandona su receptáculo, descrito como maniobra positiva.

Durante las primeras seis semanas de vida, debido a inmadurez fisiológica y a la hiperlaxitud, una cadera luxable puede ser normal. En ese período, debe realizarse un seguimiento clínico.

Se considera patológica a la persistencia de esta inestabilidad después de las seis semanas

de vida, momento en el cual se deriva al especialista en Ortopedia infantil.

Con estas dos maniobras podemos clasificar los diferentes tipos de cadera patológica, a saber:

a) Cadera inestable: cuando el signo de Barlow es positivo.

b) Cadera luxada reducible: cuando el signo de Ortolani es positivo

c) Cadera luxada irreducible: cuando presenta una importante limitación de la abducción y no se logra la reducción mediante la maniobra de Ortolani. En estos casos es útil el estudio radiológico que mostrará el fémur ascendido.

Es de relevancia pesquisar asociación con síndromes o malformaciones congénitas. El pie talo es el llamado centinela de esta patología. Al examen físico este pie presenta una deformidad en flexión dorsal, reducible, de simple tratamiento.

Si presenta hiperextensión o luxación congénita de las rodillas, hay que corregir la luxación de la rodilla inicialmente.

El niño deambulante con cadera luxada presenta con mayor frecuencia acortamiento femoral, claudicación de la marcha, y signo de Trendelenburg +.

	Clínica	Estudio
Normal	Normal	negativo
Displasia	Normal Limitación de la abducción	Positivo -Ángulo alfa <60° -Reims <50% -Índice acetabular >30°
Inestable	Barlow y ortolani positivo Limitación de la abducción	Positivo -Eco inestable -Índice acetabular >30° -Rx positiva -Disminución del espacio de reims
Luxada reducible	Barlow negativo Ortolani positivo Limitación de la abducción Asimetría de pliegues Asimetría de miembros inferiores	Ecografía positiva Rx: índice acetabular + línea de chiodin + ombredanne positivo
Luxada irreducible	Barlow y ortolani negativos Limitación de la obducción Asimetría de pliegues Asimetría miembros inferiores	Eco: cadera luxada Rx: idem anterior Luxación ascendida Neocotilo

Métodos complementarios de diagnóstico

El método de elección en lactantes menores de cuatro meses es la ecografía, la cual debe solicitarse entre el segundo y cuarto mes; y de manera inmediata ante factores de riesgo, signos clínicos positivos y en caso de duda.

Permite visualizar las estructuras no osificadas y diferenciar los componentes cartilaginosos del acetábulo y la cabeza femoral de otras estructuras blandas como la cápsula, el labrum y los músculos. Permite identificar el núcleo de osificación unas dos semanas antes de que se visualice en las radiografías. Puede realizarse desde el primer mes de vida.

La técnica ecográfica más utilizada es la técnica de Graff, que permite obtener una imagen coronal estática de la cadera en posición lateral. Esta técnica exige la correcta colocación de los puntos de referencia a partir de los cuales se trazan unas líneas que permiten determinar dos ángulos, α y β , siendo los parámetros principales:

— Una línea base que une el extremo del acetábulo óseo con el punto de inserción de la cápsula articular al periostio, y que es paralela al ala ilíaca; el punto distal del íleon; el centro del labrum acetabular; la línea del labrum acetabular y la línea del techo acetabular.

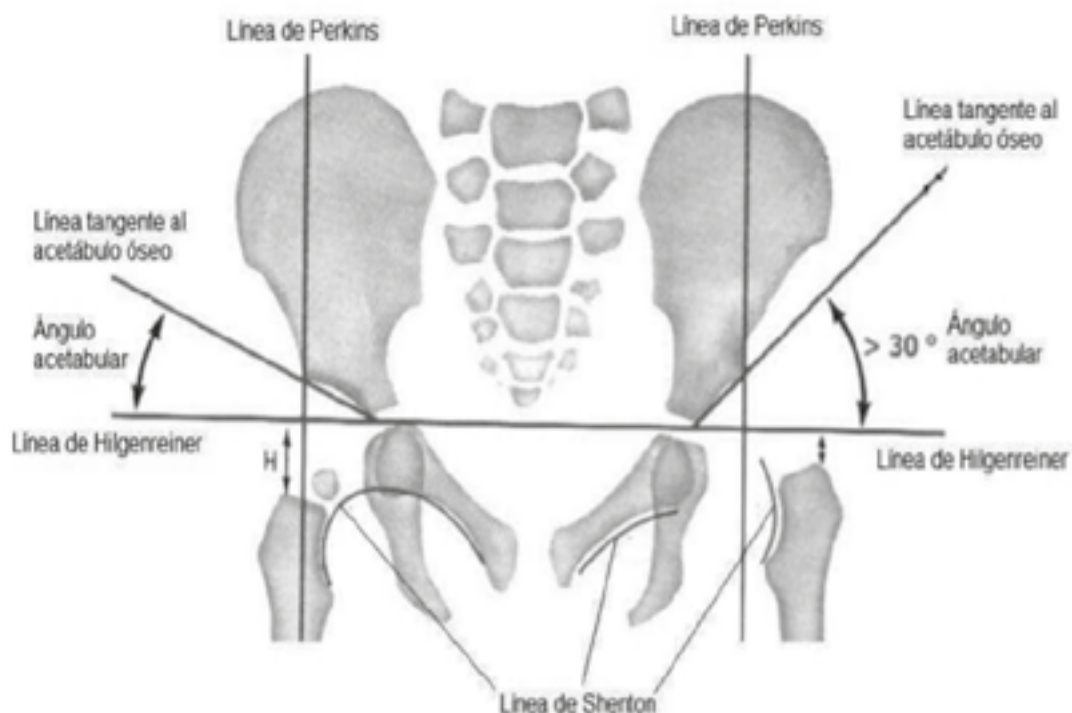
— El ángulo alfa (α) formado entre la línea ace-

tabular y base, mide el grado de formación del extremo óseo del acetábulo y la concavidad de la fosa acetabular, o sea, el grado de oblicuidad del cotilo. El ángulo alfa debe de ser mayor de 60° ; un ángulo menor es patológico, indicando un acetábulo poco profundo u oblicuo. Cuanto menor sea el ángulo, mayor será la displasia.

— El ángulo beta (β) está formado por la línea base y la de inclinación, reflejando el reborde cartilaginoso y la proporción de cabeza femoral cubierta por el acetábulo cartilaginoso. El ángulo beta debe de ser menor de 55° y un valor mayor, indicaría un desplazamiento lateral de la cabeza femoral.

A partir de los 4-6 meses de edad se produce la osificación de los núcleos cefálicos, siendo habitual en caderas normales su aparición en las radiografías hasta los 14 meses de edad. En este grupo etario es de elección la radiografía de ambas caderas con rodillas al cenit.

La radiografía simple nos aporta datos indirectos sobre la situación de la cabeza femoral en el cotilo hasta que tiene lugar el completo desarrollo del núcleo cefálico, y para ello son de utilidad una serie de referencias basadas en la tríada descrita por Putti: el aplanamiento del acetábulo con engrosamiento y oblicuidad del techo, el desplazamiento de la cabeza femoral hacia arriba y afuera y el retraso del desarrollo



del núcleo de osificación.

Antes de la aparición de los núcleos de osificación se utilizan las líneas de Chiodin, las cuales se trazan tangencialmente al borde del cuello femoral y del acetábulo. En las caderas luxadas, las mismas se cruzan antes de la línea media.

Las referencias en una radiografía anteroposterior de pelvis son las siguientes:

- Línea de Hilgenreiner: línea horizontal que une el punto más inferior de ambos ilíacos a nivel del cartílago trirradiado.

- Línea de Perkins: línea vertical, perpendicular a la línea de Hilgenreiner, a nivel del borde externo del acetábulo.

- Cuadrante de Ombredanne: Se obtiene del cruce de las líneas de Hilgenreiner y de Perkins. En una cadera normal el núcleo epifisario femoral debería de localizarse en el cuadrante interno inferior; en el caso de una subluxación se localizará en el cuadrante lateral inferior, mientras que en la luxación completa se localiza a nivel externo superior.

- Línea de Menard-Shenton: Es una línea virtual que surge de la prolongación del arco interno del cuello femoral con el borde interno del agujero obturador de la pelvis, existiendo una interrupción de dicha línea en el caso de las caderas luxadas.

- Índice acetabular. Es el ángulo formado entre la línea de Hilgenreiner y una línea trazada a lo largo del techo acetabular; su valor en un recién nacido debe de ser menor de 30° para ir disminuyendo hasta los 20° en los niños de dos años de edad. Este ángulo será mayor cuanto más inclinado esté el acetábulo. Un ángulo mayor a 40° se considera patológico.

En los niños mayores es difícil determinar el índice acetabular debido a la osificación del cartílago trirradiado y por eso se utiliza el índice de Sharp, equivalente al índice acetabular, pero en vez de utilizar como línea base la línea de Hilgenreiner utiliza una línea que une las lágrimas de Khöler a nivel del borde superior del agujero obturador; este ángulo debe de ser menor de 40°.

Se reserva la artrografía para caderas luxadas con dificultad para su reducción. Se han podido identificar los obstáculos anatómicos para la reducción como son el aspecto anteromedial de la cápsula articular, el ligamento transverso acetabular, entre otros.

Tratamiento

En el paciente con cadera luxable, si tiene más de 6 semanas de vida y la inestabilidad persiste se derivará al especialista en Ortopedia Infantil. En estos casos se suele utilizar la técnica de triple pañal (método de tratamiento poco fiable, al no asegurar la contención), el Arnés de Pavlik o una férula de abducción como la férula de Von Rosen y la almohada de Frejka.

En el lactante mayor de seis meses es preferible usar otro tipo de ortesis como la de Lorrach o similares.

El paciente con cadera luxada debe ser derivado al especialista de Ortopedia Infantil para tratamiento. En los casos reductibles por debajo de los seis meses de edad, el tratamiento de elección es el arnés de Pavlik (dispositivo dinámico que produce una abducción de la cadera manteniendo la congruencia articular). El arnés debe ser colocado y revisado semanalmente por un especialista, que comprobará si la cabeza femoral está bien reducida. Si no se consigue la reducción en 3 semanas se abandonará este tratamiento. Si permanece bien reducida, el arnés debe mantenerse durante 3-4 meses, retirándolo de forma progresiva una vez que se haya objetivado una correcta reducción de la cadera.

Ante el fracaso de la reducción con el arnés de Pavlik, si el paciente todavía no cumplió los seis meses de edad se continuará el tratamiento incruento con otro tipo de ortesis en abducción.

Si el paciente cumplió los seis meses, el siguiente paso deberá ser intentar la reducción cerrada y/o abierta, previo período de tracción tipo Briant (al cenit). Actualmente el método de elección es la reducción abierta por vía interna (Weinstein)

En los casos irreductibles, el tratamiento dura hasta los 6 meses aproximadamente. Primero se utiliza el arnés de Pavlik, y en caso de no conseguir la reducción a las 2-3 semanas, efectuaremos tracción continua con abducción progresiva. Esta última pauta es la que se hace inicialmente, cuando el diagnóstico se efectúa después de los 6 meses de edad y el tratamiento es quirúrgico.

En el paciente con cadera luxada de diagnóstico tardío, se requerirá siempre la derivación al especialista en Ortopedia Infantil. En estos casos se exige un período preliminar de tracción hospitalaria previo a la reducción cerrada y/o abierta.

La cirugía de la displasia acetabular se utiliza exclusivamente para completar una reducción quirúrgica o corregir secuelas.

En cualquier caso, aunque se hayan normalizado los parámetros de la cadera, estos niños pueden desarrollar una displasia tardía, por lo cual es necesario el seguimiento hasta la maduración esquelética.

Prevención

La función del Pediatra será la detección precoz de la displasia de cadera para la prevención secundaria y derivación oportuna al especialista de Ortopedia y Traumatología infantil; y así darle la oportunidad al lactante menor de poder realizar un tratamiento conservador. Si la detección es tardía, se manifiesta la enfermedad, y en ese caso será primordial la prevención terciaria, ya que si no se realiza el tratamiento quirúrgico, se generan severos trastornos funcionales, con acortamiento en miembros y claudicación en la marcha. Por ende las secuelas son severas, incapacitantes y prevenibles.

Si el tratamiento conservador se realiza en tiempo y forma podemos tener como resultado una cadera sin secuelas.

En algunos casos puede persistir una displasia acetabular residual como secuela del tratamiento de la DDC, así como también complicaciones a futuro del tratamiento incruento o invasivo, pero como resultados mediatos se mejora la calidad de vida del niño.

Comentario del especialista

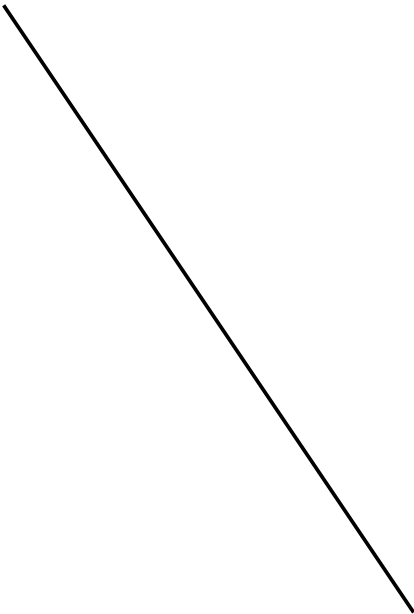
La displasia del desarrollo de la cadera tiene una incidencia muy alta en la sociedad y sus secuelas son graves para la función de la cadera y la posibilidad de realizar tareas sociales y laborales por culpa de las mismas.

El alta de tratamiento podría considerarse recién después de finalizado el crecimiento, dada la cantidad y calidad de las complicaciones que tiene la enfermedad y sus tratamientos.

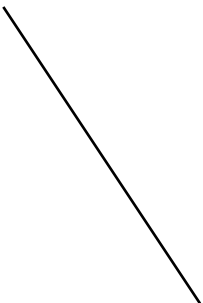
Considero la búsqueda sistemática clínica, fundamentalmente de los pacientes con los estadios tempranos de esta enfermedad, para evitar la mayoría de las secuelas.

Bibliografía

- Abril, J.C. ; Vara Patudo, I.; Egea Gamez, R.M.; Monero Díaz, M. *Displasia del desarrollo de la cadera y trastornos ortopédicos del recién nacido. Pediatría Integral. Madrid 2019.XXIII(4): 176-86*
Dovasio, M.F; Kucharczyk, M.C; Kreindel, T.G; San Román, J. *Displasia del desarrollo de la cadera. Archivos Argentinos de Pediatría. 2006; 104(6):563-565.*
Jiménez, R. *Protocolos diagnósticos de la Asociación Española de Pediatría. Luxación congénita de cadera. Asociación Española de Pediatría. España, 2008.Capítulo 48: 457-460*
Revenga Giertych, C.; Bulo Concellón, M.P. *Displasia del desarrollo de la cadera. Hospital Universitario. Puerto Real (Cádiz). Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Rev. S. And. Traum. y Ort., 2001;21(2):195-206.*



NÚCLEO SITUACIONES CLÍNICAS



Categoría **F**

DESNUTRICIÓN Y BAJA TALLA

Hospital Zonal General de Agudos. Héroes de Malvinas de Merlo.
Servicio de Pediatría



Dr. Roberto Intani

Jefe de Servicio

Dra. Marianela Boto

Dra. Miriam Huanca

Instructora Pediatría

Dra. Guadalupe Laime

Dra. Angélica Palomino

Dra. Nigel López

Dra. Karen Barrios

Dra. Shirley Huanca

Residentes 3° año

Dr. Fernando Bustamante

Dra. Betty Martínez

Residentes 4° año

DESNUTRICIÓN

Sumario

En el niño, el estado de nutrición está estrechamente relacionado con su salud y es el que permite la expresión de su potencial de crecimiento y desarrollo. La enfermedad aguda grave y, sobre todo, los procesos crónicos condicionan, por diversos mecanismos, un importante deterioro de la nutrición tanto mayor cuanto más incide sobre periodos de crecimiento acelerado en los que la situación de balance energético negativo va a ser más acentuado. Incluso la propia hospitalización, con frecuencia, favorece este deterioro no sólo por circunstancias ligadas a la propia enfermedad, sino también porque se subestima la necesidad de un apoyo nutricional mucho más cuidadoso que en condiciones ambulatorias.

Caso clínico

Motivo de consulta: Paciente de sexo masculino de 15 meses de edad, consulta por cuadro clínico de varios meses de evolución aproximadamente 7 meses, con deposiciones desligada

número de 3 o 4 por día que no rebalsa pañal, sin sangre sin mucosidad, afebril siempre, con buena tolerancia oral y pérdida relativa de peso.

Consulta a un centro de salud, le indican medidas higiénicas dietética, oligoelementos, y solicitan estudios de laboratorio y control continuo. Por presentar pocas pautas de alarma por los padres, se dificulta el seguimiento de control.

Paciente clínicamente y hemodinámicamente compensado, normohidratado. Fenotipo Normal, delgado, disminución relativa de masa muscular, desarrollo madurativo acorde edad.

Se decide su internación con diagnóstico diarrea crónica, asociado a bajo peso y baja talla, para realizar estudios complementarios y una adecuada evaluación nutricional.

Antecedentes Perinatales: RNT (38 semanas)/PAEG (3.195 gr) Pc 50-25, Talla de nacimiento (50 cm) Pc 50, perímetro cefálico (36 cm) Pc 50-97, embarazo no controlado parto vaginal-cefálico. Serología maternas negativas.

Vacunas completas, recibe aportes de vitamina y sulfato ferroso a partir de los 4 meses de edad, de forma discontinuo. Lactancia materna hasta los 7 meses, introducción de semisólido 8 meses de edad.

Internado a los 7 meses de edad, por deshidratación moderada, secundario gastroenteritis.

Padres sanos de 20 y 25 años constitucionalmente de estatura mediana y delgada. Bajos recursos económicos, con escolaridad primaria incompleto, ocupación padre albañil y madre ama de casa.

Alimentación diaria: interrogatorio dificultoso, la mamá no especifica comidas con mucho detalle, refiere alimentación variada, 4 veces al día, lactancia materna a libre demanda aproximadamente 5 veces al día, alimentos generalmente dados por la madre, sin dificultad.

Exploración física

Antropometría actual:

Peso: 7180kg (Pc <3) Z score -3.3

Talla: 72 cm (Pc < 3) Z score -2.9

Perímetro cefálico 43.6 cm (Pc <3) Z score menor -2

Blanco genético 168 cm

Rango genético: entre 177 y 159 cm

Velocidad de crecimiento: 10 cm (pc3)

Peso/talla: 70%

Talla/edad: 91%

Desnutrición moderada: déficit 28.2%

Antecedentes familiares:

Tía materna con celiacía.

Madre: 20 años Talla 1.57 cm (SDS -0.6) menarca 13 años

Padre 25 años Talla 1.67 cm (SDS -0.8)

Laboratorios: GB 14.900, Hb 11.1, Hcto 33.1%, VCM 76, HCM 25.4, CHCM 33.4; Plaquetas 324.000, formula leucocitaria: neutrófilos 20%, linfocitos 52%, monocitos 4%, eosinófilos 24%, basófilos 0%,

VSG 5, calcio total 10, P 5.6, Mg 2.4, BT 0.2; BD 0.1; FAL 207, TGO 34, TGP 14, PT 6.9; Alb 4.3, Na 138, K 4.8, Cl 103. EAB normal, función renal normal vitamina D normal, perfil tiroideo normal, serología HIV negativo, Ac. Enfermedad celiaca negativo, Ig E L.V normal, Ig E trigo normal. Prolactina, cortisol y GH/IGF-1: dentro de límites normales

RX mano y muñeca izquierdo acorde edad.

Coprocultivo negativo coprovirologico negativo copoparasitologico negativo.

Recibió tratamiento empírico con metronidazol

Interpretación de laboratorio: leucocitosis leve, eosinofilia moderada, resto dentro de límites normales. Anemia leve

Sedimento urinario: no patológico

Urocultivo: positivo E. Coli (>100000 UFC/ml),

sensible a cefalexina y nitrofurantoina, resistente a ampicilina, ampicilina sulbactam y TMS.

Diagnósticos: desnutrición crónico reagudizado, bacteriuria asintomática, eosinofilia moderada. Baja Talla en estudio.

Recibió tratamiento con cefalexina 80 mg/kg/día por bacteriuria asintomática por diez días.

Ecografía renal y vesical: normal, urocultivo control postratamiento: negativo

Por eosinofilia moderada se solicita: Ecografía abdominal: normal, fondo de ojo: normal, ecocardiograma: normal, serología para Toxocara IgG positiva IgM negativa.

Se encuentra con seguimiento con: Gastroenterología, nutrición, nefrología y endocrinología.

Antropometría previa: Se trasladan los datos previos a las curvas de referencia la SAP, de peso y talla en niños varones de 0 a 24 meses.

Curvas de referencia OMS, de peso en niños varones 0 a 24 meses

Se observa descenso de peso gradual a partir de los 5 meses hasta los 7 meses de edad, del p 25 al 10, alimentación lactancia exclusiva. Continúa con descenso de peso progresivo a partir de los 7 meses de edad, del p10 al menor p3, donde a los 7 meses de edad es internado por Deshidratación moderada, secundario gastroenteritis. Manteniéndose estancamiento ponderal en los últimos 8 meses, de p 25 a p <3. Y continúa con diarrea.

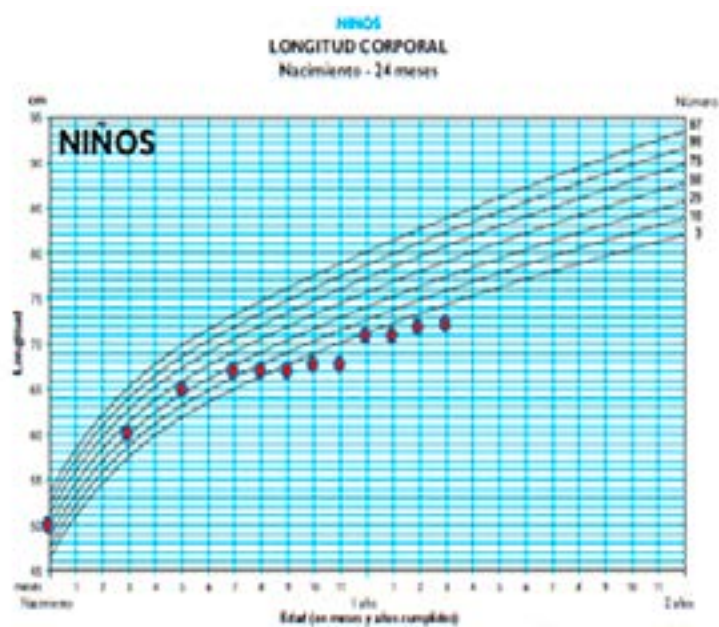
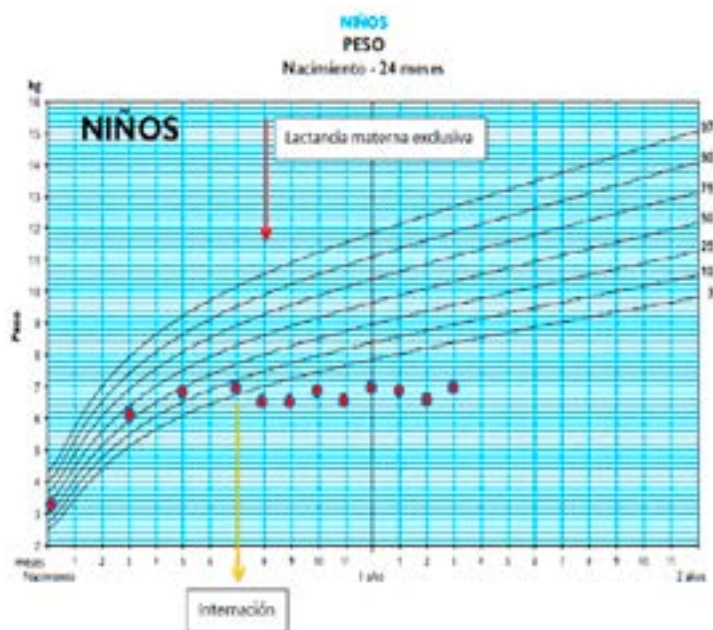
Se observa descenso de la talla a partir de los 8 meses pasando del p10 a p <3, manteniéndose paralelo p<3 en los últimos 7 meses.

Se observa descenso del perímetro cefálico a partir de los 8 meses, pasando del p10 al <p3, manteniéndose paralelo menor al p<3 en los últimos 7 meses.

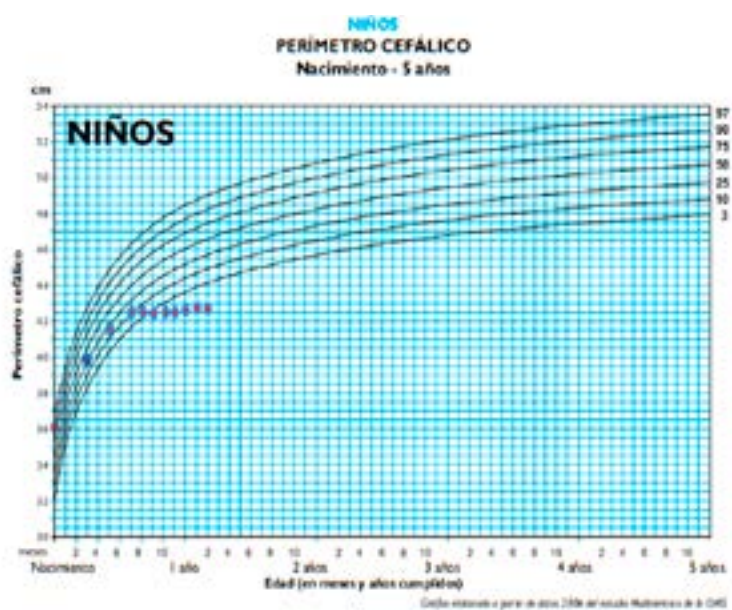
Desnutrición Infantil

Definición

La desnutrición ha sido definida como un estado provocado por la deficiencia a nivel celular de la provisión de nutrientes y/o energías necesarias para que el organismo se mantenga en buen estado, pueda desarrollar actividad, crecer y reproducirse. Es una de las causas más frecuentes de morbilidad infantil en el mundo, siendo directa o indirectamente responsable de aproximadamente el 50% de las muertes en menores de 5 años.



Curvas de referencia OMS, de talla en niños varones 0 a 2 años



La desnutrición es el producto del cúmulo de circunstancias adversas que rodean la vida de un niño, desocupación, pobreza extrema, violencia familiar y social, ruptura de la estructura familiar, desesperanza, falta de accesibilidad a la salud y a los medicamentos básicos.

La malnutrición no solo afecta las formas clínicas severas de desnutrición (marasmo y kwashiorkor), sino también formas leves, caracterizados entre otros indicadores por déficit en uno o más de los índices antropométricos, y los excesos, es decir el sobrepeso. La forma más frecuente de malnutrición es nuestra población infantil son las carencias específicas de micronutrientes (por ej. Anemias), que no pueden diagnosticarse a partir de la antropometría.

Se define como peso $< Pc 10$ según la OMS, clásicamente se definió siempre como $pc < 3$ (pero definiendo con el $Pc 10$ se puede actuar más tempranamente, prevención).

Cuando se llega a un $Pc < 3$ ya se produce deterioro a nivel de la pared intestinal y esto impide una adecuada realimentación, produce intolerancia.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN

La desnutrición se desarrolla gradualmente a lo largo del tiempo. Este proceso permite ajustes metabólicos y de los compartimientos biológicos, que resultan de una disminución de la necesidad de nutrientes y en un equilibrio nutricional compatible con una disponibilidad más baja de nutrientes por las células.

Movilización de Energía

La disminución de energía, produce disminución de gasto energético con periodos cortos de actividad física y de juegos. Si es muy severa difícilmente se compensa, porque la grasa corporal se usa como sustrato, lo que produce reducción del tejido adiposo y pérdida de peso. La masa magra disminuye lentamente; el catabolismo de proteínas musculares produce aminoácidos libres, particularmente alanina que se usa como sustrato de energía en la gluconeogénesis. La concentración de glucosa en sangre permanece normal por largo tiempo a expensas de aminoácidos glucogénicos, pero si el paciente presenta infecciones o ayuna durante seis o más horas se produce hipoglucemia.

Una de las consecuencias del menor gasto

energético es que el niño presenta dificultades para el mantenimiento de la temperatura corporal normal. Si la fiebre tiene algún factor protector ante la infección, el desnutrido presenta una grave desventaja.

Metabolismo de Proteínas

La baja disponibilidad de proteínas, reduce la síntesis de proteínas corporales, tienden a conservar las proteínas esenciales y a mantener sus funciones. De esta manera modifican la síntesis y alteran la actividad de diversas enzimas, así como la síntesis de proteínas hepáticas. Por el bajo aporte de proteínas el 90 al 95% de aminoácidos son reciclados, además existe un aumento de la vida media de las proteínas. Simultáneamente se produce movimiento de albumina del espacio extravascular al intravascular, lo cual contribuye a mantener niveles adecuados de albúmina circulante. Si la deficiencia es severa los mecanismos adaptativos ya no son suficientes, entonces se reduce particularmente la albumina, como consecuencia cae la presión oncótica y existe salida de agua hacia el espacio extravascular, que contribuye al edema. Al respecto existen teorías que llevan al niño o niña al edema, como son los cambios bioquímicos producidos por los radicales libres que pueden dañar la membrana celular, produciendo Edema, infiltración grasa y lesiones de la piel, y estos pueden aumentar como consecuencia de infecciones, traumatismos o exposición prolongada a la luz, y ciertos catalizadores como el hierro.

Por lo tanto, la producción de radicales libres permite el consumo de nutrientes como consecuencia de esto disminuye la vitamina C, vitamina A (beta carotenos) y vitamina E, además de proteínas como la ceruloplasmina, Transferrina, hefaestina y la transferrina que ligan el hierro y facilitan la oxidación. Los radicales libres pueden ser eliminados por las superóxido dismutasa, de zinc, cobre, manganeso, o la glutatión peroxidasa dependiente de selenio.

Cambios Endócrinos

Existe reducción de actividad hormonal, involucrada en el aumento de las reservas corporales tales como las hormonas tiroideas, que posibilitan una menor oxidación de glucosa, disminución del gasto basal de energía, así como las funciones no vitales relacionadas con el crecimiento, como: la insulina, el factor de cre-

cimiento similar a la insulina (IGF-1), y las gonadotropinas. Por el estrés del hambre, puede haber un aumento de la lipólisis y aumento de la gluconeogénesis, que inhiben la secreción de insulina.

La actividad de los glucocorticoides está normal o elevada, lo cual favorece el catabolismo de las proteínas musculares, lipólisis y gluconeogénesis. La capacidad funcional del eje hipotálamo hipofisario-suprarrenal, se mantiene normal, expresado en el aumento o normalidad de la relación renina: aldosterona, lo que ocasiona aumento de la retención de sodio o agua y la consecuente producción de edemas, que permite respuestas metabólicas y endócrinas adecuadas ante condiciones de estrés. La hormona de crecimiento puede estar aumentada en niños edematosos.

Cambios y demanda de Oxígeno

La reducción en el número de eritrocitos y la baja concentración de hemoglobina, se ve frecuentemente en pacientes con Desnutrición Proteico energética (DPE), son parte de los fenómenos de adaptación relacionados con las necesidades tisulares de oxígeno. Los niños desnutridos tienen menores demandas de oxígeno debido a la reducción de la masa corporal y su menor actividad física. El niño desnutrido tiene reservas de hierro relativamente altas y conserva la capacidad de producir eritropoyetina y reticulocitosis, en réplica a una respuesta aguda. Sin embargo pueden desarrollar una anemia funcional severa, además de deficiencia de proteínas y energía.

Funciones Cardiovasculares y Renales

La circulación central predomina sobre la periférica, expresado por la frialdad de extremidades. El débito cardíaco y la presión arterial disminuyen, así como los reflejos cardiovasculares se ven afectados, lo que produce hipotensión postural y disminución del retorno venoso.

Desequilibrio Inmunológico

Como consecuencia de la anorexia y catabolismo acelerado causado por una infección, se deprime la respuesta inmunitaria lo que vuelve más vulnerable de contraer infecciones al niño o niña. Además las infecciones tienden a ser más largas. El timo se encuentra disminuido a valores inferiores de 150mm², lo que dificulta

la madurez de poblaciones linfocitarias, siendo posible esta medición mediante ecografía.

Movilización de Electrolitos

El intercambio de sodio y potasio está alterado, lo cual produce una pérdida de potasio y entrada de sodio a nivel intracelular. Esto puede conducir a una sobrehidratación intracelular. La pérdida de potasio intracelular y la reducción en la masa muscular produce una disminución del potasio corporal total. Estas alteraciones también contribuyen a la fatiga, reducción de la fuerza musculo-esquelética y la reducción de la motilidad intestinal.

Funciones Gastrointestinales

La actividad de las disacaridasas intestinales, las secreciones gástricas, pancreáticas y la producción de bilis disminuye en los pacientes severamente desnutridos, lo cual afecta la digestión y absorción de carbohidratos, aminoácidos y lípidos.

Sistema Nervioso Central y Periférico

Cuando existe DPE a temprana edad puede haber retraso en el crecimiento neuronal, del cerebro, mielinización de los nervios, producción de neurotransmisores y la velocidad de conducción nerviosa.

Clasificación y Diagnóstico

De acuerdo a su etiología: cuando se realiza el análisis nutricional de un paciente, es imperioso determinar el origen de la carencia de los nutrientes, a esta se divide en tres:

- Primaria: por falta de aporte alimentario. Se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente; por ejemplo, zonas marginadas los niños presentarían carencias físicas que afectarían directamente el estado nutricional.
- Secundaria: por enfermedades que alteran el estado nutricional. Cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se interrumpe el proceso digestivo o absorción de los nutrientes; el ejemplo más claro son las infecciones del tracto digestivo que lesionan las vellosidades del íleon y limitan la absorción.
- Mixta o terciaria: cuando la coexistencia de ambas condicionan la desnutrición. Por ejemplo: un niño con leucemia que se encuentre en fase de quimioterapia de inducción a la remisión

presentara en el proceso eventos de neutropenia y fiebre asociados a infecciones que condicionen catabolia y poca ingesta de alimentos, por lo tanto la causa es la suma de las dos.

Para comprender la etiología de una desnutrición primaria debemos analizarla no como un hecho biológico, si no como una variable más dentro del contexto de una comunidad. Tiene su origen en aspectos económicos, antropológicos, sociológicos y culturales. En ella participan la marginación, el subdesarrollo, la educación sanitaria y las infecciones repetidas.

De acuerdo a la composición corporal:

- Emaciación: déficit de peso mucho mayor que el déficit de talla (peso bajo, talla normal), con relación P/T disminuida. Gran disminución de masa magra, y del TCS. Desnutrición reciente, aun no hubo adaptación metabólica a las carencias calóricas. Tienen alto riesgo de enfermar y morir. La rehabilitación nutricional provoca rápido aumento de peso en pocas semanas.
- Acortamiento: déficit de peso y talla equivalentes, relación P/T conservada.

No se asocia a mayor morbilidad ni riesgo de infecciones y/o muerte. La prolongación de la carencia en el tiempo produce adaptación metabólica que le permite al niño sobrevivir con un mínimo aporte calórico. Tienen lenta respuesta a la alimentación.

De acuerdo al tiempo de evolución

- Desnutrición Aguda: alteración del peso pero la talla se conserva. Disminuye la relación P/T.
- Desnutrición Crónica: se afecta también la talla, la relación P/T se encuentra conservada.

Bmi o IMC se utiliza para obesidad más que para desnutrición. Es muy sensible para aumento de peso pero muy poco sensible para bajos Pc.

La desnutrición es más frecuente en menores de 2 años de edad, y el BMI no sirve para esta edad, sirve para evaluar desnutrición en niños más grandes. (Adolescentes).

Otro modo de clasificar el grado de desnutrición a través del Puntaje z o puntaje estandarizado el cual especifica en qué medida un valor determinado se aparta de la media (P50).

La manera de calcularlo es:

Puntaje z=

Medida actual – mediana o percentil 50 para la edad / DE

Se considera:

- Desnutrición moderada entre -2 y -3 DE
- Desnutrición grave mayor de -3 DE

Clasificación por grado y tiempo: este punto es el más complicado de determinar, debido a que existen diversas formas e instrumentos utilizables para su ejecución.

México ha sido uno de los países pioneros en el estudio de la desnutrición. El Dr. Federico Gómez realizó una clasificación. Aún vigente en documentos como la Norma Oficial Mexicana: en esta se divide en grados.

Clasificación de Gómez: clasificación de la gravedad de la desnutrición (% de déficit de peso en relación al Pc 50), es generalmente utilizada a nivel epidemiológico en niños entre 0 y 24 meses. No diferencia una situación actual o pasada, y ha sido pensada para la evaluación del riesgo de muerte sobre todo en desnutridos graves.

El índice antropométrico utilizado es el peso para la edad. La fórmula utilizada es la siguiente:
 $\% P/E = \text{Peso real} \times 100 / \text{peso que le corresponde para la edad}$

Los resultados se interpretan, de acuerdo con el déficit, de la siguiente manera:

- Normal: 0- 10%
- Grado 1: (leve): 11-24% del peso corporal: no presenta alteraciones muy evidentes en el examen físico.
 - Peso ponderal lento
 - Puede estar irritable
 - Apetito variable
 - Puede haber diarreas alternadas con constipación
 - Infecciones más frecuentes y prolongadas (de más lenta absorción)

Diagnóstico: estudio de curva ponderal

- Grado 2: (moderado): 25-40% del peso corporal.
 - Adelgazamiento
 - Se detiene la altura
 - Masas musculares hipotrofias
 - Apatía que alternan con irritabilidad
 - Infecciones repetidas, prolongadas, tórpidas, con complicaciones (mayormente respiratorias y gastrointestinales)
 - El desnutrido pierde y acumula líquido con facilidad (alteración del balance hídrico).
 - Disminución de la tolerancia a los alimentos (vómitos y diarreas al aumentar los aportes nutricionales).

- Grado 3: (grave o severa): mayor del 40% del peso corporal (con edemas)

- Deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas

- Administración excesiva de líquidos

- Síndrome de realimentación

- Insuficiencia cardíaca

- Infecciones no diagnosticadas y no tratadas

- Anemia grave

- Insuficiencia hepática

- Hipoglucemia e hipotermia

La desnutrición con presencia de edemas siempre es grave.

Clasificación de Gómez: gravedad de la desnutrición (% de déficit de peso en relación al Pc 50).

Grado 1 (leve): 11-24%

Grado 2 (moderado): 25-40%

Grado 3 (grave) mayor 40%

No ofrece al clínico si se trata de un evento agudo o crónico.

Clasificación de Waterlow: es la mejor herramienta ya que la diferencia radica en que permite determinar la cronología y la intensidad de la desnutrición. Relaciona Peso/Talla y Talla/Edad, es útil en niños mayores, entre 1 y 5 años, y en aquellos estudios de poblaciones en los que no se puede precisar una edad exacta. Esta clasifi-

cación es habitualmente usada en la planificación de recursos.

Para la realización de esta evaluación se necesitan dos indicadores:

$\% (P/T) = \text{Peso real} \times 100 / \text{peso que debería tener para la estatura}$

$\% (T/E) = \text{estatura real} \times 100 / \text{estatura que debería tener para la edad}$

Con el fin de determinar el peso para la talla y la talla para la edad, es necesario tomar el valor que corresponde al percentil 50 en las gráficas de crecimiento.

Una vez que se han obtenido los porcentajes, se ubican en el gráfico y el resultado de las mediciones puede ser el siguiente:

- Eutrófico o Normal: cuando el peso para la talla y la talla para la edad se encuentran dentro de valores adecuados para la edad.

- Desnutrición aguda: (emaciación) peso para la talla bajo y talla para la edad normal.

- Desnutrición crónica recuperada o en homeorresis: (o también llamada aguda y crónica) talla para la edad alterada y peso para la talla normal.

- Desnutrición crónica agudizada: talla para la estatura alterada y peso para la talla baja. Y por intensidad será

- Grado I: menos del 90%

- Grado II: entre el 80 y 89%

- Grado III: menos del 79%

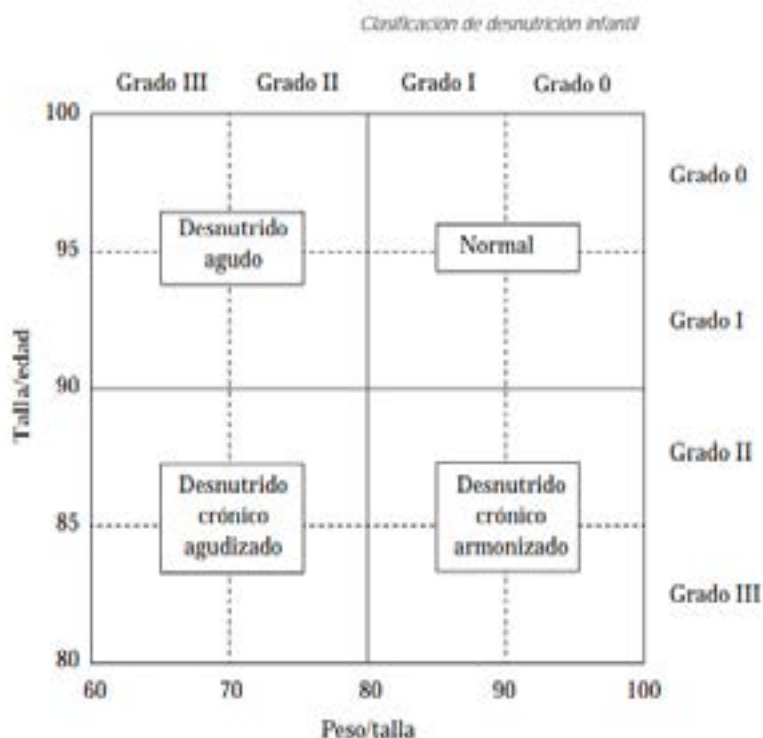


Figura 2. Clasificación por Waterlow.

De acuerdo al tipo de carencia:

- **Marasmo:** se presenta en niños pequeños menores de 1 año con periodo de lactancia materna cortos. Presenta severas alteraciones en la relación Peso/Edad y Peso/Talla. La apariencia clínica es más bien de emaciación con disminución de todos los pliegues, de la masa muscular y tejido adiposo; la talla y los segmentos corporales se verán comprometidos. La piel es seca, plegadiza. El comportamiento de estos pacientes es con irritación y llanto persistente, con posición de flexión por el hipertonio.

Los pacientes que la presentan se encuentran más adaptados a la de privación de nutrientes. Este fenómeno se debe a que cuentan con niveles incrementados de cortisol, una reducción en la producción de insulina y una síntesis de proteínas eficiente por el hígado a partir de las reservas musculares.

Las complicaciones más frecuentes son las infecciones respiratorias, del tracto gastrointestinal, así como la deficiencia específica de vitaminas. La recuperación, una vez iniciado el tratamiento, es prolongado.

- **Kwashiorkor:** se presenta mayores de uno año, asociada a la pobreza por alto aporte de hidratos de carbono y bajo e proteínas en la dieta. Son niños que muestra edemas generalizados más acentuados en miembros inferiores, pelo atrófico, con declaración en bandas y de tinte rojizo; piel hiperpigmentada, con hiperqueratosis, descamada; presencia de queilitis, xeroftalmia y raquitismo.

El edema y el hígado graso son los signos más destacables dentro del kwashiorkor.

El depósito hepático de lípidos es preferentemente de triglicéridos dada la síntesis deficiente de lipoproteínas de muy baja densidad que son los responsables del transporte de los mismos. La disfunción hepática puede progresar hasta manifestarse con ictericia y fenómenos hemorrágicos, ambos signos de mal pronóstico.

Así mismo, existe un estado alterado de las defensas oxidativas del organismo que se asocia directamente a las dietas inadecuadas. A pesar de ello, no ha sido demostrado claramente que los niños que presenta kwashiorkor sean deficientes en factores antioxidantes como son el beta caroteno, la vitamina E, el selenio o el Zinc.

Pueden cursar con alteraciones hidroeléctricas caracterizadas por hipokalemia e incremento del tercer espacio. Cursan con hipoalbuminemia e

hipoproteinemias marcadas. Una vez que se inicia el tratamiento la respuesta es acelerada y satisfactoria. Las complicaciones más asociadas son infecciones del aparato respiratorio y digestivo.

- **Kwashiorkor-marasmático o mixta:** Es la combinación de ambas entidades clínicas, esto es cuando un paciente presenta desnutrición de tipo marasmática que puede agudizarse por algún proceso patológico (infecciones por ejemplo) que ocasionará incremento del cortisol de tal magnitud que la movilización de proteínas sea insuficiente, las reservas musculares se agoten y la síntesis proteica se interrumpa en el hígado ocasionando hepatomegalia, llegando a una hipoalbuminemia que disminuye la presión oncótica desencadenando el edema.

TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN

Sin complicaciones centro de recuperación nutricional ambulatorio.

Debe cumplir los siguientes criterios:

- Apetito conservado
- Edema no tener
- Clínicamente estable
- Situación socio familiar propicia

Con complicaciones: pasos a tener en cuenta:

- **Hipoglucemia:** control de glucemia, aportar glucosa oral o ev.
- **Hipotermia:** mantener y controlar la T° Corporal
- **Deshidratación:** Hidratación cuidados con soluciones que contengan Na^{+} y K^{+}
- **Electrolitos:** Aportar suficiente k, Mg. P.(correcciones)
- **Micronutrientes:** Aportar Ca, Cobre, zinc, sulfato ferrosos, multivitamínicos y ácido fólico.
- **Infección severa:** Administrar tto antibiótico.
- **Alimentación prudente:** Mantener una baja carga de proteínas y volumen
- **Recuperación de crecimiento:** Aportar una dieta rica densa en energía, proteínas. Y los nutrientes esenciales que sea fácil de digerir:
- **Estimulación sensorial:** Estimular el desarrollo emocional y sensitivo.
- **Preparación para el seguimiento**

1.- FASE DE ESTABILIZACIÓN: 1 a 7 días durante esta fase se debe de corregir la DHT, si existe se tratará la infección

Si el niño no es capaz de comer de una taza o un biberón, es preferible alimentarlo mediante

una sonda nasogástrica antes que por vía parenteral.

2.- FASE DE REHABILITACION: De 2-6 semanas el niño muestra más interés por su entorno y su apetito ha comenzado a volver a su normalidad.

TRATAMIENTO ALIMENTARIO

Recuperación nutricional, una vez compensado el paciente comienza esta etapa con la introducción de una dieta que aporte los requerimientos;

- Calórico /proteico:
- Al inicio 80-100 kcal/kg/día y 1gr/kg/día de proteínas
- Estos aportes se aumentan progresivamente cada 48 a 72 hrs
- Hasta llegar a 150-200 kcal/kg/día y 3-4 gr/kg/día de proteínas.
- Aporte de vitaminas y minerales:
- Vit A 3000 a 5000 ui/d.
- Vit D 1000 ui/d.
- Vit C 50 ui/d.
- Vit b12 2 mcg/d.
- Mg 3-5 meq/kg/d.
- Cobre 2.4 meq/kg/d
- Potasio 5-10 meq/kg/d.
- Calcio 5 meq/kg/d.
- Ac. Fólico 1000 mcg/d.
- Zinc 300-450 meq/d o 10-15mg/d.
- No introducir hierro hasta que se encuentre sin diarrea y con franca recuperación nutricional.

La DNT tiene múltiples facetas, por lo que su solución a escala nacional requiere una comprensión, confianza, y cooperación entre los distintos organismos gubernamentales.

SÍNDROME DE RETROALIMENTACIÓN

El síndrome de realimentación (SR) es un cuadro clínico complejo que ocurre como consecuencia de la reintroducción de la nutrición (oral, enteral o parenteral) en pacientes malnutridos. Los pacientes presentan trastornos en el balance de fluidos, anomalías electrolíticas –como hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia– alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y déficits vitamínicos. Esto se traduce en la aparición de complicaciones neurológicas, respiratorias, cardíacas, neuromusculares y he-

matológicas. En este artículo se han revisado la patogenia y las características clínicas del SR, haciendo alguna sugerencia para su prevención y tratamiento. Lo más importante en la prevención del SR es identificar a los pacientes en riesgo, instaurar el soporte nutricional de forma prudente y realizar una corrección adecuada de los déficits de electrolitos y vitaminas.

Comentario

En este caso se pone en evidencia la sumatoria de factores que confluyen para que se produzca la desnutrición al descartarse causas patológicas.

Factores relacionados con la madre como inadecuada nutrición y periodo intergenesico corto.

Factores alimentarios que se relacionan con mala calidad de los alimentos, escasa cantidad de nutrientes de origen animal e inadecuadas prácticas de alimentación,

Infecciones recurrentes que se asocian a entornos contaminados y mala higiene que altera la absorción de los alimentos y de los micronutrientes.

También coexisten los factores del entorno doméstico: pobreza, negligencia, bajo nivel educativo de los padres, estimulación inadecuada, inseguridad alimentaria y no acceso al agua potable.

Bibliografía

-
- Fernández A. Rev. Desnutrición en niños Hospital Ludovica (La plata) Instituto Nacional de Estadística Bolivia. Información estadística. INE-Bolivia. 2011 [cited 2011 Jun].
- Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. Información estadística. INE-Bolivia. 2011
- OMS. Propuesta actualizada por la OMS en el tratamiento de la desnutrición grave. Revista Cochabambina de Pediatría.2010; 17:2-8
- Sevilla R, Corrales JA. Volver a sonreír: De la clínica a la comunidad y de la comunidad a la clínica. 2ª ed. Cochabamba-Bolivia; 2006.
- Sevilla R, Zalles L, Belmonte G, Jambon B, Chevalier Ph, Parent G, Dehnnin JM. Inmunosupresión e Inmunorestauración en niños desnutrición proteico energética grave. Gaceta Médica Boliviana. 2009; 32:5-12.
- Sevilla R, Zalles L, Belmonte G, Jambon B, Chevalier Ph, Parent G, Dehnnin JM. Inmunosupresión e Inmunorestauración en niños desnutrición proteico energético
- Sevilla R, Zalles L, Holguín A, Espada C, Melgarejo E. Estudio comparativo de la estrategia boliviana "CLAPSEN"
- Sevilla R, Zalles L, Sejas E, Belmonte G. Estimulación de las poblaciones linfocitarias del niño con malnutrición proteico energética grave. Gaceta Médica Boliviana. 2001; 24:32-36.
- Sevilla R, Zalles L. Manual mochila nutricional. Bolivia: IRD; 2011. p.70.

BAJA TALLA

Sumario

La talla baja constituye uno de los principales motivos de consulta en Pediatría y, por ende, en Endocrinología Pediátrica. De ahí la importancia de efectuar una correcta valoración del crecimiento y desarrollo del niño que permita una adecuada orientación diagnóstica y terapéutica.

EL CRECIMIENTO Y SU EVALUACIÓN

El crecimiento es un proceso complejo en el cual intervienen diversos factores y uno de los mejores indicadores del estado de salud del niño. De hecho, el retraso en el crecimiento puede ser la primera manifestación de distintos procesos patológicos subyacentes, tanto congénitos como adquiridos.

Para la valoración de la talla deberemos considerar los distintos factores que intervienen e interaccionan en su correcto desarrollo:

- Factores endógenos: genéticos (talla diana y patrón de desarrollo y maduración), hormonales, étnicos, metabólicos y receptividad de los tejidos diana.

- Factores exógenos: nutritivos, afectivos, ejercicio (la práctica regular de ejercicio adecuado es beneficioso, no así el de competición o alto rendimiento).

De este modo, la talla adulta se verá influenciada por la interacción de estos factores y aunque esta estará condicionada genéticamente, la expresión de esta potencialidad dependerá del estado de salud y nutrición del niño.

El crecimiento longitudinal es un proceso continuo, pero no lineal, distinguiéndose tres fases en la etapa postnatal:

1. Lactancia: caracterizada por un crecimiento rápido durante los dos primeros años de vida.

2. Infancia: caracterizada por una velocidad relativamente constante de alrededor de 5-7 cm por año.

3. Pubertad: caracterizada por un estirón puberal entre 8-12 cm al año, dependiendo del sexo.

La evaluación del crecimiento y desarrollo requiere una estrecha relación entre los diferentes niveles de atención pediátrica, primaria y especializada. Asimismo, es importante contar con herramientas (estadiómetros, balanzas, orquímetro de Prader, gráficas de talla, peso y velocidad de crecimiento, entre otros) y conoci-

miento de las técnicas de valoración.

Medidas, valoraciones y cálculos matemáticos utilizados en la clínica

- Longitud (hasta los dos años de edad) y talla, posteriormente. En el análisis de la evolución del crecimiento se debe tomar en consideración no solo en qué percentil o SDS de talla se encuentra el paciente ($\text{SDS de la talla actual} = \frac{\text{talla actual en cm} - \text{media [P50 de talla para edad actual en cm]}}{\text{DE [desviación estándar]}}$), sino que es fundamental la evaluación de la velocidad de crecimiento ($\text{velocidad de crecimiento} = \frac{\text{talla actual} - \text{talla anterior}}{\text{edad actual} - \text{talla anterior}}$).

- Talla sentado y envergadura, que permitirán el análisis de los segmentos corporales.

- Peso y cálculo del IMC (peso/talla^2) para la valoración nutricional.

- Evaluación de la maduración ósea, considerando normal o concordante aquella que está en más o menos un año con respecto a la edad cronológica del paciente. Para su valoración existen diferentes métodos, aunque el más utilizado es el de Greulich y Pyle y para el cálculo de pronóstico de talla adulta el método de BayleyPinneau.

- Maduración sexual por medio del uso de los estadios de Tanner, donde el estadio 2 representa el inicio de la pubertad; es importante recordar que en la niña el botón mamario y en el varón unos testes de 4 cc indican la puesta en marcha del eje hipofisogonadal.

Fundamental es también contar con tablas y gráficas de referencia poblacionales actualizadas. También se comparará el crecimiento del niño con su familia, para lo que nos valdremos del cálculo de la talla diana (TD varón: $\text{talla del padre} + \text{talla de la madre} + 13/2$; TD mujer: $\text{talla del padre} + \text{talla de la madre} - 13/2$). El conocimiento de la auxología, las técnicas de medición y los cálculos matemáticos permitirá una evaluación del crecimiento apropiada.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

La talla baja se define como aquella que se encuentra situada por debajo de -2 DE para edad y sexo en relación a la media de la población de referencia.

En general, cuanto mayor es la desviación de la talla con respecto a la media de la población y/o con respecto al potencial genético de crecimiento de la familia, mayor será la probabilidad de encontrar una patología subyacente.

Durante el crecimiento es regulado:
 Durante el embarazo: nutrición, insulina IGF-1
 Infancia: nutrición, IGF-1
 Niñez: GH/IGF-1
 Pubertad: GH/IGF-1, esteroides sexuales
 En la práctica clínica se ha clasificado en dos tipos, las variantes normales (talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento) y las patológicas. Actualmente, sin embargo, se prefiere clasificar la talla baja en talla baja patológica y talla baja idiopática (figura 1).

Talla baja idiopática

La talla baja idiopática (TBI) hace referencia a todas aquellas condiciones de talla baja en la que desconocemos la causa de la misma y que, además, cumplen los siguientes criterios: longitud y peso del recién nacido normal para la edad gestacional, proporciones corporales normales, ausencia de enfermedad crónica, orgánica, endocrinopatía o trastornos psicoafectivos, nutrición adecuada y un tiempo de crecimiento o maduración que puede ser normal o lento. Se ha propuesto, además, clasificar a los niños con talla baja idiopática en relación a la pubertad:

- Antes de la pubertad, en función de si la talla del paciente se encuentra dentro o por debajo del rango genético o talla diana; se le denominaría talla baja familiar y no familiar, respectivamente.
- Después del inicio de la pubertad, en función de si iniciaron la pubertad a su hora o con retraso. Según esta propuesta, la talla baja familiar y la no familiar podrían asociarse con una pubertad normal o retrasada.

En la práctica clínica se continúa utilizando los términos de talla baja familiar (TBF) y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD), debido a que nos permiten abordar de una forma práctica en la consulta la talla baja idiopática (TBI) y, sobre todo, porque facilita la orientación al paciente y su familia. El diagnóstico de TBF se realiza por exclusión y la garantía diagnóstica la proporciona únicamente la propia evolución. No se puede catalogar a un paciente como portador de la misma solo por cumplir con los criterios de talla baja y tener algún antecedente familiar positivo, si no ha sido sometido a un estudio completo. Los antecedentes familiares demostrarán la existencia, en efecto, de una talla baja materna y/o paterna o de otros miem-

Patológica:	a) desproporcionada: displasias esqueléticas, raquitismo b) proporcionada: -Prenatal: RCIU (factores maternos, patología placentaria e infecciones), síndromes dismórficos, trastornos cromosómicos. -Posnatal: de origen psicosocial, malnutrición, enfermedades crónicas (gastrointestinales, cardiopulmonares, infecciones renales, hematológicas), enfermedades endocrinas, iatrogenia.
2.- Idiopática.	

Clasificación de la talla baja: (figura 1)

bros. Es importante resaltar que no siempre que los padres sean bajos va a tratarse de una TBF, ya que la presencia de este dato no excluye al niño/a de poder padecer además otras causas de retraso de crecimiento tratables. Debemos considerar que un paciente presenta talla baja familiar cuando cumple con los siguientes criterios diagnósticos: peso y longitud normales al nacimiento, talla por debajo de -2 SDS para edad, sexo y población de referencia, antecedentes familiares de talla baja, proporciones corporales normales, velocidad de crecimiento normal, pubertad normal, edad ósea concordante, pronóstico de talla adulta semejante a talla diana, talla final baja y ausencia de enfermedad orgánica, endocrina, nutricional o carencia afectiva. El RCCD, sin embargo, se ha descrito como un enlentecimiento en el ritmo de maduración. Desde el punto de vista de la herencia, su comportamiento es autosómico dominante, por lo que está ampliamente difundido en la población en la que podemos encontrar hasta en un 50% de familias uno o dos sujetos afectados; además, en los niños existirá el antecedente en uno o ambos padres en un 60 hasta un 80%. El diagnóstico de retraso constitucional no puede establecerse de entrada, en una primera consul-

ta, sino más bien de forma evolutiva, según sea no solo la situación estatural actual sino también su evolución puberal. La clínica del retraso constitucional viene marcada por una longitud y peso neonatal normales, con una velocidad de crecimiento adecuada durante un periodo de tiempo variable, seguida de una desaceleración. A partir de los 7-8 años puede darse ya una ralentización del crecimiento, con una ganancia anual que, con frecuencia, no supera los 3 cm/año. El estirón y el desarrollo, propios del periodo puberal, se retrasan 2-4 años con respecto a lo habitual, debutando con un retraso similar al de la edad ósea. La presentación de la pubertad se corresponde mejor con la edad ósea que con la edad cronológica. Una vez que se inicia la pubertad, la progresión de los caracteres sexuales y del crecimiento lineal sigue un ritmo normal. En relación a la talla final, hay divergencia de opiniones. Algunos autores señalan que sería normal; sin embargo, otros indican que no siempre es así, ya que de un 10 a un 20% quedarían por debajo de los límites normales, lo que hace pensar en alguna circunstancia que no les permite desarrollar su potencial genético. La coincidencia de más de un trastorno del crecimiento puede modificar la presentación clásica del retraso constitucional. Particularmente, la talla baja familiar que exacerba la disminución de la estatura. Estos niños pueden ser muy bajos, de manera que se presentan como un verdadero reto para el diagnóstico diferencial con otras causas de talla baja patológica.

Talla baja patológica

En este se engloban todas las causas conocidas que pueden ocasionar efectos negativos en la evolución normal de la talla. Se pueden subclasificar en función del análisis de las proporciones corporales (figura 1), que nos orientará hacia la etiopatogenia, distinguiendo aquellos niños con talla baja y proporciones normales (armónicas) de los segmentos corporales de los que presentan talla baja con proporciones corporales inadecuadas (disarmónicas).

Proporcionada

Se debe valorar el momento del inicio de la desviación del crecimiento, y según este podemos diferenciarlas en formas:

Prenatales

- Retraso del crecimiento intrauterino, el niño pequeño para edad gestacional (PEG): los niños

nacidos con un crecimiento prenatal restringido o limitado se agrupan bajo este término, que engloba a aquellos recién nacidos cuyo peso y/o longitud se sitúa por debajo del límite inferior de lo normal para su edad gestacional. Si bien muchos de estos niños van a presentar una recuperación de su crecimiento antes de los dos años de edad, en algunos (aproximadamente 1 de cada 10) el retraso persistirá. Hoy día se sabe que en el niño PEG puede persistir con retraso de crecimiento postnatal y con cambios metabólicos y en la composición corporal que podrían estar implicados en el origen del síndrome metabólico en el adulto. En los casos en los que no se evidencia una recuperación del crecimiento a los cuatro años de edad, está indicado el tratamiento con hormona de crecimiento (tabla 1).

- Síndromes dismórficos: en muchas ocasiones dan lugar a un hipocrecimiento de origen intrauterino. Se identifican por sus peculiaridades clínicas (facies peculiar, malformaciones asociadas y, en la mayoría de los casos, talla baja y retraso psicomotor) y radiográficas. El tipo más frecuente de evolución en estos trastornos es un ritmo constantemente lento del desarrollo lineal, desde la vida prenatal temprana hasta lograr la talla del adulto. La importancia de realizar el diagnóstico en estos pacientes radica en poder dar un pronóstico adecuado y en realizar consejo genético.

- Cromosomopatías: la mayoría suelen cursar con retraso de crecimiento. Cabe destacar entre ellas el síndrome de Turner, que también es una indicación de tratamiento con hormona de crecimiento (tabla 1).

Tabla 1. Hormona de crecimiento: indicaciones aprobadas para uso.	
Indicación	Dosis
Déficit de hormona de crecimiento	0,025-0,035 mg/kg/día
Síndrome de Turner	1,4 mg/m ² /día SC
Insuficiencia renal crónica	0,045-0,050 mg/kg/día
Síndrome de Prader-Willi	1,0 mg/m ² /día SC
Pequeño para edad gestacional	0,035-0,067 mg/kg/día
Deficiencia de crecimiento debida a alteración en el gen SHOX	

Postnatales

- Hipocrecimientos de origen psicosocial: este síndrome se caracteriza por talla baja o retraso de la pubertad, o ambas, en niños y adolescentes, en asociación con hostigamiento psicológico o privación emocional, y para el cual no existe otra explicación.

- Hipocrecimiento de origen nutricional: la malnutrición severa es la causa más frecuente de hipocrecimiento.

- Hipocrecimientos en las enfermedades crónicas: las enfermedades crónicas son causa frecuente de retraso del crecimiento. En algunos casos este efecto no es importante y, desde luego, de mucho menor relevancia que el problema de base. Sin embargo, hay ocasiones en que puede dar lugar a una afectación importante del crecimiento.

- Enfermedad gastrointestinal: existe una frecuente asociación entre la enfermedad crónica intestinal y el retraso de crecimiento. Enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la fibrosis quística cursan con trastornos del crecimiento.

- Enfermedades cardiopulmonares: la enfermedad cardíaca crónica por lo general secundaria a defectos congénitos, tiene efectos particularmente negativos sobre el crecimiento. Entre las enfermedades respiratorias crónicas que se asocian a retraso del crecimiento destacan la fibrosis quística y el asma crónica severa.

- Enfermedad hepática: las causas de hipocrecimiento en las hepatopatías son varias. Por un lado, implican una desnutrición por malabsorción de grasas a las que se añade anorexia, disminución de la síntesis proteica, etc. Si el origen es un error metabólico (glucogénesis), pueden asociar hipoglucemia. Por otro lado, el hígado es el lugar de síntesis de las IGF, por lo que sus niveles estarán disminuidos junto a niveles altos de GH.

- Enfermedad hematológica: la anemia crónica severa puede contribuir al retraso de crecimiento, tanto si se trata de una enfermedad hemática primaria o bien acompañando a otras enfermedades crónicas.

- Insuficiencia renal crónica (IRC): la talla final alcanzada por individuos que durante su niñez desarrollaron IRC es considerablemente más baja que la talla final predicha cuando se presentó la primera manifestación de insuficien-

cia renal. Es una indicación de tratamiento con hormona de crecimiento (tabla 1). Otras enfermedades renales que podrían condicionar hipocrecimiento serían las tubulopatías crónicas (acidosis tubular renal, hipercalcemia idiopática, tubulopatías congénitas complejas) y las nefropatías intersticiales y glomerulares crónicas.

- Infecciones crónicas e inmunodeficiencias: las infecciones crónicas o recurrentes pueden ser causa de un hipocrecimiento, y más si se unen a una nutrición deficiente, hechos más evidentes en ambientes de bajo desarrollo socioeconómico. Serían responsables entre otros el déficit de ingesta de nutrientes y el aumento de las necesidades energéticas. En estos niños es posible un crecimiento recuperador una vez superada la noxa.

- Metabolopatías: muchos errores congénitos del metabolismo se asocian a hipocrecimiento. La causa puede estar en un déficit en la síntesis de metabolitos esenciales o en el aumento de sustancias tóxicas que se depositan entre otros órganos, en el hueso y glándulas endocrinas.

- Hipocrecimiento en las enfermedades endocrinológicas:

- Déficit de GH: constituye alrededor del 5% de las causas de talla baja. En el crecimiento el eje hormonal más importante en el crecimiento postnatal es el de la hormona de crecimiento, aunque también influyen otros sistemas hormonales como las hormonas tiroideas, la insulina, cortisol y esteroides sexuales. El eje somatotrofo es el principal responsable del crecimiento y cualquier alteración en su funcionamiento puede repercutir en el crecimiento. El trastorno puede ser hipofisario (primario), suprahipofisario (secundario) o bien por resistencia periférica a la GH o a los IGF (periférico). En el primer caso es insuficiente tanto la secreción espontánea como la inducida por fármacos; en los suprahipofisarios la liberación espontánea de GH es anormal, pero la respuesta puede ser normal tras estímulo con GHRH (déficit de GHRH) o cuando se utilizan otros estímulos farmacológicos. En los trastornos periféricos la producción de GH es normal o incluso elevada, pudiendo existir una resistencia periférica por alteración del receptor de GH (síndrome de Laron), alteraciones postreceptor (señalización intracelular anómala) o una resistencia periférica a los IGF-1.

Los hechos clave de la historia clínica que pueden indicar la existencia de déficit de GH son (tabla 2)

TABLA 2. Algunas características clínicas del niño con déficit de GH

- Talla baja
- Velocidad de crecimiento disminuida (documentada por una cuidadosa auxología en un intervalo mínimo de 12 meses)
- Hipoglucemia
- Micropene
- Exceso de grasa subcutánea
- Retraso de la maduración ósea
- Pubertad retrasada
- Pico de respuesta de GH < 10 ng/ml en las pruebas de estimulación
- Posible asociación de otros déficits hormonales (PRL, TSH, ACTH, FSH, LH)

Los criterios auxológicos a valorar para iniciar la investigación en la búsqueda del diagnóstico de déficit de GH son: a) el paciente presente una talla baja importante, más de 3 DS por debajo de la media; b) la talla esté a más de 1,5 DS por debajo de la talla media parental; c) la talla esté a más de 2 DS por debajo de la media y que la velocidad de crecimiento esté durante un año a más de 1 DS por debajo de la media para la edad cronológica o que exista una disminución de la DS de la talla de más de 0,5 durante un año en niños mayores de dos años; d) en ausencia de talla baja, una velocidad de crecimiento más de 2 DS por debajo de la media durante un año o más de 1,5 DS de forma sostenida durante dos años; e) signos indicativos de lesión intracraneal; f) signos de deficiencia combinada de hormonas hipofisarias; g) signos y síntomas de déficit de GH en el neonato. Una vez que se han analizado los hechos clínicos y los criterios auxológicos, la sospecha clínica de déficit de GH debe ser confirmada mediante otras exploraciones complementarias: bioquímica hormonal para el estudio de la secreción de GH, estudios radiológicos y genéticos.

En la tabla 3 se indican las causas de deficiencia de hormona de crecimiento:

- Déficit idiopático: en la mayoría de las ocasiones el déficit de hormona de crecimiento es de origen desconocido.
- Déficits genéticos: el único criterio necesario para sospecharlos es la presencia de un déficit

TABLA 3. Causas de deficiencia de hormona de crecimiento

Idiopática
Congénita
• Genéticas • Asociada con defectos estructurales del cerebro – Agenesia del cuerpo calloso – Displasia septoóptica – Holoprosencefalia – Encefalocele • Asociadas con defectos de la línea media – Fisura palatina, labio leporino – Displasia septoóptica – Holoprosencefalia – Incisivo central único
Adquirida
• Traumáticas – Trauma perinatal – Trauma postnatal • Infecciosas – Meningitis o encefalitis • Tumores del sistema nervioso central – Craneofaringioma – Germinoma hipofisario – Adenoma hipofisario – Glioma óptico • Otras – Histiocitosis – Enfermedades granulomatosas – Irradiación craneal – Postquimioterapia – Deprivación psicosocial – Hipotiroidismo

grave de GH. La consanguinidad de los padres aumentará la sospecha de un trastorno recesivo.

- Déficits secundarios a lesiones hipotálamo-hipofisarias: la alteración del hipotálamo-hipofisis puede deberse a alteraciones congénitas: malformaciones del sistema nervioso central (displasias septoópticas, holoprosencefalia, disgenesia hipofisaria y otras anomalías de la línea media), o bien ser secundaria a lesiones adquiridas como tumores (craneofaringioma, germinoma), histiocitosis, traumatismo craneoencefálico grave, radioterapia craneal.
- Alteraciones en la secreción de GH: se debería a una alteración en el control neuroregulador

de la GH que produciría una secreción alterada o disminuida. Se trata, por tanto, de un concepto fisiopatológico, englobándose dentro de los llamados déficits “no clásicos” de GH, en los que falta el fenotipo peculiar de los clásicos, pero que cursan con talla baja y que responden al tratamiento. Por último, en determinadas situaciones se ha demostrado una disminución de la secreción de GH, pero en este caso de carácter reversible, ya que se normalizaría al desaparecer el factor causal (obesidad extrema, enfermedad de Cushing, tratamiento con corticoides, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, la carencia afectiva, el fallo renal y hepático).

- Alteración en el mecanismo de acción de la GH: dentro de este grupo de trastornos destaca el síndrome de Laron o síndrome de insensibilidad a la GH, que se debe a un defecto molecular en el receptor de GH que conduce a una incapacidad para sintetizar el factor de crecimiento IGF-1.

- Déficit múltiple de hormonas hipofisarias: se define como la deficiencia de GH asociada a la de una o más hormonas hipofisarias. El déficit múltiple de hormonas hipofisarias usualmente se presenta en la infancia con hipoglucemia, como resultado de la combinación del déficit de ACTH que conduce a hipocortisolismo, y déficit de hormona de crecimiento. La presencia de micropene, producto de la deficiencia prenatal de LH, hipoglucemia e ictericia es prácticamente sugestivo del diagnóstico de hipopituitarismo congénito. El hipotiroidismo de origen hipofisario puede estar presente, aunque suele tener una presentación posterior.

El tratamiento en el déficit de GH es la hormona de crecimiento y los casos en que se demuestre la deficiencia primaria de IGF-1 se utilizarán el tratamiento con IGF-1 recombinante.

- Hipotiroidismo: algunos niños con formas leves de hipotiroidismo pueden ser esencialmente normales tanto en apariencia como en grado de inteligencia, si bien presentan retraso de crecimiento y de la maduración ósea. En definitiva, en estos casos, la talla constituye la única alerta.

- Diabetes mellitus: se puede producir un hipoprecimiento si la enfermedad debuta antes de la pubertad y más, si se asocia a un mal control.

- Hipoprecimiento en el hipogonadismo: en estos niños, la pubertad va a estar ausente o incompleta, con ausencia de “estirón puberal” por falta de “impregnación” esteroidea en el

momento de la pubertad. No todos los hipogonadismos asocian talla baja, algunas entidades como el Klinefelter, presentan una talla superior a la normal.

- Pubertad precoz: en la pubertad precoz y en la hiperplasia suprarrenal congénita además de un desarrollo sexual acelerado, se produce una maduración ósea y crecimiento lineal muy rápidos, con cierre precoz de los cartílagos epifisarios que conduce a una talla baja final.

- Hiperkortisolismo: en muchos de los casos el hiperkortisolismo es de origen iatrogénico por administración de esteroides exógenos por diferentes vías de administración. En cualquiera de los casos, las manifestaciones clínicas serán secundarias al exceso de glucocorticoides independientemente de la causa y estas incluyen obesidad de tipo centrípeto, plétora facial, hirsutismo, acné, estrías violáceas en abdomen, giba dorsal, hipertensión arterial en el 72% de los casos y hasta en un 15% de los casos hiperglucemia, entre otros. La talla baja es un hallazgo habitual en el síndrome de Cushing.

- Patología paratiroidea: la talla baja, aunque puede asociarse al hipoparatiroidismo, es más frecuente en el pseudohipoparatiroidismo, especialmente en el tipo a, presentando además estos pacientes unos rasgos peculiares que conforman el denominado “fenotipo de Albright”.

- Iatrogenia: en primer lugar, hay que hacer mención a la Corticoterapia, por su clara efectividad en el tratamiento de muchos procesos y su difusión en muchas de las especialidades médicas y pediátricas. Tenemos claro ahora que tienen algún efecto sobre el crecimiento, actuando en al menos tres niveles: tienden a reducir la producción hipofisaria de GH, interfieren con la producción hepática de IGF y tienen profundos efectos sobre la síntesis proteica en el cartílago de crecimiento.

Desproporcionada

La exploración se orientará en la búsqueda o detección de signos de raquitismo o displasias óseas.

Displasias esqueléticas

Las alteraciones esqueléticas son causa frecuente de talla baja de tipo desproporcionado. Se clasifican en osteodisplasias (se asocian a alteraciones primarias en la consistencia e integridad del hueso) y en condrodisplasias (anomalías primarias del hueso y del cartílago). Actualmen-

te se diferencian más de 300 formas clínicas por el fenotipo, las características radiológicas y la forma de herencia. Las displasias óseas, en su conjunto, tienen una incidencia de 1:4100 en el momento del nacimiento. Entre las claves que pueden sugerirnos este diagnóstico estarían las siguientes: talla baja extrema, historia familiar muy evocadora (muchas displasias son dominantes), proporciones corporales anormales y alteraciones de las extremidades del tronco. Su identificación se puede realizar ya intraútero y, aunque habitualmente se hace al nacer, en ocasiones puede tardarse en reconocerlas. Es exigible una cuidadosa medida de los segmentos corporales y un estudio radiológico óseo. La nomenclatura internacional de las enfermedades óseas constitucionales, en su última revisión, propone una clasificación que incorpora datos del diagnóstico molecular. En algunos casos se valora el tratamiento quirúrgico para la elongación de miembros el cual debe ser realizado por un equipo con experiencia. También alteraciones en el gen SHOX que causan las discondrosteosis o síndrome de Leri weill y el síndrome de Langer, está indicado el tratamiento con hormona de crecimiento (tabla 1).

Raquitismo

El déficit de vitamina D puede conducir a un hipocrecimiento desproporcionado, con malformaciones óseas asociadas. En el raquitismo hipofosfatémico, ya sea en su forma familiar o hereditaria, aparece también una talla baja desproporcionada.

DIAGNÓSTICO/VALORACIÓN DEL PACIENTE

A pesar de que inicialmente el diagnóstico de la talla baja parezca sencillo, cada una de sus posibles causas debe ser evaluada. Para ello se realizará una correcta historia clínica.

Antecedentes personales

- Datos de la gestación (tiempo, número de fetos, enfermedades maternas, tóxicos maternos), factores que afectan a la nutrición y crecimiento del feto y, por tanto, también al tamaño del recién nacido. Valorar posibles lesiones del parto (instrumentales, podálica, asfixia).

- Peso, longitud del recién nacido y perímetro cefálico.

- Estado nutricional desde el nacimiento, así como situación socioeconómica.

- Evolución del desarrollo psicomotor.

- Tiempo de evolución de la talla baja y antecedentes de cualquier enfermedad, valorando posibles signos o síntomas asociados (hipoglucemia, ictericia prolongada al nacimiento).

- Búsqueda de problemas psicológicos, sociales, familiares, escolares, entre otros.

Antecedentes familiares

La herencia influye de manera significativa en la talla, por lo se debe investigar:

- Talla de padres, hermanos y otros familiares cercanos, y también datos del fenotipo de los padres. Estos datos orientarán sobre la posible presencia de talla baja familiar o genética.

- Edad de desarrollo de los padres (aparición de caracteres sexuales secundarios, menarquia de la madre).

- Enfermedades familiares de posible carácter hereditario. Antecedentes de consanguinidad.

Exploración física

La valoración clínica incluirá:

- Evaluación auxológica (peso, talla, envergadura, perímetro cefálico, talla sentado, medidas de segmentos corporales). Todas estas medidas antropométricas están estandarizadas en tablas de normalidad para distintas poblaciones por edad y sexo. Se obtendrá la talla o longitud mediante un estadiómetro o un infantómetro, dependiendo de la edad del niño, recordando que la talla en decúbito será mayor que en bipedestación, por lo que puede llevar a errores de interpretación cuando se cambia de instrumento de medida.

- De mayor interés que la medida de la talla en un momento puntual, es la determinación de la velocidad de crecimiento (expresado en cm/año), que deberá incluir un periodo entre seis meses y un año. Así, independientemente de la talla, una velocidad de crecimiento disminuida (< P10) es indicativa de que el niño debe ser estudiado para buscar la causa que condiciona el retraso de crecimiento. Todas estas medidas se compararán con las curvas de crecimiento de referencia.

- Valoración nutricional/encuesta dietética.

- Es fundamental una valoración del nivel de desarrollo o grado de madurez alcanzado para obtener datos aproximados de la "edad biológica". Así, la valoración conjunta de los datos aportados por la maduración sexual (cambios puberales), la maduración ósea y determinados

TABLA 4. Metodología de estudio: datos fundamentales de la historia clínica y la exploración física

Evaluación. Historia clínica	Interpretación
Longitud, peso y perímetro cefálico del recién nacido. Edad gestacional	Comparar con los estándares de crecimiento intrauterino y descartar si es pequeño para edad gestacional (PEG)
Investigar hallazgos prenatales (retraso del crecimiento intrauterino, infecciones, intoxicación por drogas) y del nacimiento (presentación podálica, asfixia, ictericia)	El retraso del crecimiento fetal puede condicionar un niño PEG y alrededor de un 15% de estos niños no hacen el catch-up de talla. Los tóxicos e infecciones afectan el crecimiento intrauterino. Alteraciones hipofisarias se han asociado con presentación podálica y también con ictericia prolongada
• Datos sobre el crecimiento • Edad de inicio de los signos de pubertad (desarrollo mamario en la niña, volumen testicular en el varón) • Enfermedades previas y medicación (por ejemplo, terapia con corticoesteroides inhalados) • Historia médica por aparatos y sistemas: búsqueda de signos y síntomas de enfermedad cardíaca, pulmonar, intestinal (distensión abdominal, dolor abdominal, constipación, diarrea), renal, endocrina, hematológica, sistema nervioso central (cefalea, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, etc.), fatiga • Nutrición	Es fundamental para la evaluación el contar con una curva de crecimiento con la mayor cantidad de datos posibles, así como contar con datos sobre la pubertad: precoz, normal o retrasada. Buscar causas latrogénicas (medicamentos) u orgánicas de talla baja. Fundamental descartar anemia y enfermedad celíaca. Síntomas sugerentes de enfermedades del sistema nervioso central (tumores, histiocitosis, sarcoidosis). La fatiga puede ser un síntoma de anemia, enfermedad celíaca, enfermedad renal
País de origen. Grupo étnico	Orienta la decisión de las gráficas de referencia a utilizar. En los niños adoptados en países en vías de desarrollo lo ideal es utilizar gráficas del país de origen en la primera generación, luego en las siguientes generaciones las del país de adopción
Consanguinidad	Su presencia incrementa a posibilidad de encontrar enfermedades genéticas
Talla de los padres (preferiblemente recogida por el médico)	Permite el cálculo de la talla diana
Valoración global del fenotipo de los padres	Observar: características dismórficas (especialmente de cara y manos), proporciones corporales
Tiempo de la pubertad de los padres (madre: menarquia; padre: inicio de vello pubiano, edad del estirón puberal)	Existe generalmente un patrón familiar en el tempo y características de la pubertad y el desarrollo
Historia familiar (enfermedades: autoinmunes, tiroideas, alteraciones del crecimiento, alteraciones óseas, enfermedades endocrinas)	Orientar una probable causa genética
Retraso intelectual	Se asocia a cuadros sindrómicos, enfermedades cromosómicas, enfermedades metabólicas

Adaptación social y psicológica: rendimiento escolar (grado, comportamiento social, actividades físicas), relaciones sociales, personalidad, actividades vitales (sueño, humor), actitud de los padres, etc	Información sobre de privación emocional, negligencia en el cuidado del niño, desnutrición. Depresión. Anorexia nerviosa. Valoración de la capacidad de relacionarse con el entorno. Impresión sobre los padres: actitud, preocupación, apoyo
---	---

Exploración Física

Medir: longitud o talla, peso, perímetro cefálico, talla sentado, envergadura, antebrazo	Talla, peso, peso para la talla, IMC y circunferencia de la cabeza comparadas con gráficas de referencia. Valorar los segmentos corporales da información para descartar displasias óseas. Una menor envergadura o antebrazo corto son sugestivos de alteraciones en SHOX
Bajo peso	Enfermedades intestinales, hipocortisolismo, enfermedades metabólicas, PEG
Sobrepeso. Obesidad (recordar que los niños con obesidad de origen nutricional son a menudo relativamente altos para su edad cronológica)	Hipotiroidismo. Síndrome de Cushing. Déficit de GH
Signos de dismorfología	Síndromes
Frente amplia, hipoplasia medio-facial	Deficiencia de GH. Resistencia a la GH. Deficiencia de IGF-1
Cara de luna. Plétora facial	Síndrome de Cushing
Tamaño del tiroides	Patología tiroidea
Frecuencia cardíaca, tensión arterial	Frecuencia cardíaca baja: hipotiroidismo HTA elevada: problemas renales, síndrome de Cushing
Distensión abdominal	Enfermedad celiaca
Hepatomegalia, esplenomegalia	Enfermedad hepática o metabólica
esplenomegalia Estadio puberal	Precoz, normal o tardío
micropene	Hipogonadismo. Hipopituitarismo
Criptorquidia	hipopituitarismo
Hipotonía muscular, atrofia muscular	Enfermedad muscular
Visión, fondo de ojo, defectos del campo visual	Patología del sistema nervioso central
Signos de privación emocional, abuso o negligencia	Privación psicosocioemocional

Nota: GHRH: factor liberador de GH, GH: hormona de crecimiento, GHBP: transportador de GH, GHR: receptor de GH, IGF1: factor de crecimiento insulino similar, IGFBP3: transportador de IGF1, ALS: sbunidad ácido lábil, transportador de IGF1

marcadores bioquímicos (hormonas sexuales, fosfatasa alcalina, hidroxiprolina) será de gran ayuda en la interpretación del proceso de crecimiento.

- Evaluación detallada por aparatos, valorando la posible presencia de estigmas o dismorfias que orienten a un síndrome determinado (por ejemplo, facies de muñeca y acromicria en el hipopituitarismo, o mixedema en el hipotiroidismo). Así es importante discernir entre el hipocrecimiento proporcionado o armónico del desproporcionado o disarmónico.
- Una buena historia clínica (tabla 4)

Exploraciones complementarias

La realización de pruebas complementarias vendrá determinada por las características auxológicas, evolución del crecimiento, datos de la historia clínica y la exploración física inicial y van dirigidas a establecer el diagnóstico etiopatogénico. La orientación diagnóstica y el plan de

estudio deben ser amplios, pero sin apresuramientos, avanzando de forma escalonada sobre la base de los datos ya conocidos. Las valoraciones aconsejables en el hipocrecimiento se muestran en la tabla 5. El perfil analítico debe incluir: hemograma, glucosa, urea, creatinina, transaminasas, proteínas, calcio, fósforo, fosfatasa alcalinas, sideremia, análisis de orina y hormonas tiroideas.

Cuando la sospecha clínica es de alteración del eje de la hormona de crecimiento, existen diferentes pruebas que nos ayudan a estudiar y conocer la funcionalidad de los elementos vinculados en el eje GH-IGF-1 (tabla 6). Unas son llamadas “fisiológicas”, como el ejercicio físico y el registro durante el sueño espontáneo o de 24 horas. Otras llamadas farmacológicas estimulan la secreción de GH con distintos fármacos (insulina, clonidina, L-dopa, propranolol, arginina, ornitina, glucagón, GHRH). Como norma general, para hacer el diagnóstico de déficit de GH deben

Tabla 5. Pruebas complementarias en la evaluación de talla baja	
Prueba	Objetivo del análisis descartar patología
Hematología, hierro, ferritina. VSG	Anemia Infecciones
Bioquímica básica: creatinina, potasio, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina	Enfermedades renales. Enfermedades del metabolismo fosfocálcico. Malabsorción
Equilibrio ácido-base	Acidosis tubular renal
Anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio. IgA total	Enfermedad celíaca
TSH, T4L	Hipotiroidismo
Orina. PH, glucosa. Proteínas	Enfermedad renal
Cortisol libre en orina (si obesidad presente)	Síndrome de Cushing
IGF-1, IGFBP-3	• Deficiencia de hormona de crecimiento • Resistencia a la hormona de crecimiento Nota: si hay alteraciones se debe completar el estudio del eje GH-IGF-1: pruebas de estimulación de GH. Test de generación de IGF
Cariotipo	Síndrome de Turner Nota: en los niños también pueden detectarse anomalías en el cariotipo, especialmente en los que presentan alguna anomalía genital
Radiografía de mano y muñeca izquierda	Maduración ósea. Puede dar también información sobre la deformidad de Madelug (alteraciones del gen SHOX). Si se observa acortamiento del metacarpo investigar pseudohipoparatiroidismo
Serie ósea (solo en caso de encontrar en la exploración auxológica desproporción en los segmentos corporales y en los que tienen una talla muy baja con respecto a la talla parental)	Displasias óseas
RNM cerebral (en niños sin clínica de patología intracraneal o defectos de línea media no hay indicación para su realización. Se realizará solo si el estudio auxológico y las pruebas bioquímicas sugieren alteración del eje GH-IGF-I)	Hipopituitarismo

ser patológicas dos de estas pruebas. Las determinaciones de IGF-1 e IGFBP-3 representan una ayuda complementaria en el diagnóstico de la deficiencia de GH. El test de generación de IGF-1 tras administración de GH, puede ser de utilidad para el diagnóstico de los síndromes de insensibilidad a la GH.

Las pruebas de estimulación de GH pueden estar influenciadas por factores que deben tomarse en consideración, tales como obesidad, hipotiroidismo e hipercortisolismo, medicación concomitante (glucocorticoides, drogas psicotrópicas), privación psicosocial que pueden alterar la respuesta de GH, tanto en los test fisiológicos como en los farmacológicos. Todas las pruebas de estimulación deben realizarse en ayunas, dado que la mayoría de los estímulos pueden ser bloqueados en presencia de niveles elevados de glucemia o de ácidos grasos libres. En cuanto a la interpretación de los resultados, la dificultad para evaluar la eficiencia de las pruebas en el déficit de GH reside en que no hay un patrón que represente adecuadamente el rango, que va de déficit moderado a severo, de esta alteración. De todas maneras se ha establecido a manera de consenso que el pico de respuesta mínimo que debe obtenerse es de 10 ng/ml para considerar que la respuesta es positiva, lo que significaría que la secreción de GH

sería normal.

Destacar los avances en genética molecular, que estudian la relación entre un determinado cambio genético y su expresión en un fenotipo clínico particular y que también se han convertido en un apoyo diagnóstico en algunos casos de talla baja. Por ejemplo en las alteraciones del gen SHOX, en déficits hormonales múltiples, déficit de GH y en la resistencia a la GH.

Cada paso en la estrategia diagnóstica debe estar orientado por una correcta interpretación e integración de todos los datos clínicos obtenidos en la anamnesis, la exploración física incluyendo auxología y pruebas complementarias, recordando siempre que la relación entre el pediatra y el endocrinólogo pediatra es fundamental.

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO

El principal objetivo de la terapia en el déficit de GH en el niño es la normalización de la talla durante la niñez, conseguir que los pacientes alcancen una talla adulta lo más normal posible y evitar las consecuencias psicológicas negativas derivadas de una estatura baja. (Tabla 1).

Posología y forma de administración

El tratamiento con hormona de crecimiento en sus diferentes indicaciones se administra por

Tabla 6. Evaluación bioquímica y respuesta terapéutica en el déficit de GH, resistencia a la GH y resistencia a IGF-1.

Diagnostico	GH (prueba de estimulación)	GH (secreción espontanea)	IGF-1	IGFBP-3	Observaciones
Déficit de GH	↓	↓	↓	↓	Excelente respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento
GH bioinactiva	n	n	↓	↓	Buena respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento
Disfunción neurosecretora de la secreción de GH	n	↓	↓	↓/n	Buena respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento
Resistencia a la GH	↑	↑	↓	↓	Terapia con IGF-1. En la resistencia parcial, dosis elevadas de hormona de crecimiento
Resistencia a IGF-1	↑	↑	↑	↑	No existe tratamiento
N: normal; ↑: elevada, ↓ disminuida.					

vía SC, diariamente y de preferencia en la noche. La dosis varía dependiendo de la indicación (tabla 1). En el déficit de hormona de crecimiento es de 25-50 µg/kg/día (0,025-0,050 mg/kg/día). El tratamiento con GH debe mantenerse hasta que el paciente alcance la talla final, entendiendo por tal cuando la velocidad de crecimiento es inferior a 2 cm/año o cuando se comprueba la fusión de las epífisis de los huesos largos.

En los niños diagnosticados de déficit de GH y, por tanto, tratados con prontitud, el cáctup de crecimiento es excelente, aunque puede estar afectado por diferentes variables, tales como el peso al nacer, la edad de inicio del tratamiento, el grado de la deficiencia, la duración del tratamiento, la frecuencia de las inyecciones de hormona, y la talla al inicio del tratamiento así como al inicio de la pubertad.

En el caso de la deficiencia múltiple de hormonas hipofisarias, en el que, como se ha señalado, al déficit de GH se asocia el déficit de una o más hormonas hipofisarias, debe realizarse la correcta monitorización y tratamiento de los diferentes déficits hormonales asociados (T4, cortisol, hormonas sexuales y hormona anti-diurética), por lo que, si existe déficit de TSH, se administrará hormona tiroidea en dosis sustitutivas. En pacientes con déficit de ACTH, la dosis de hidrocortisona no debe superar los 10 mg/m² /24 horas y, durante las enfermedades intercurrentes o procesos operatorios, se debe incrementar la dosis. Si faltan las gonadotropinas, se administran esteroides gonadales cuando la edad ósea alcanza la edad en la que suele producirse la pubertad.

Vigilancia del tratamiento

Debe realizar el pediatra endocrinólogo y el seguimiento debería ser cada 3-6 meses. La respuesta en el crecimiento (incremento de la talla y velocidad de crecimiento) es el parámetro más importante en la monitorización. Por tanto, en el seguimiento del paciente se efectuará siem-

pre la valoración auxológica, a fin de conocer su evolución, haciendo los ajustes oportunos en la dosis del tratamiento, con estudio de la edad ósea una vez al año. También son útiles, para garantizar el cumplimiento y la seguridad, la valoración de los niveles de IGF-1 e IGFBP-3.

Seguridad y efectos secundarios

La tolerancia es, en general, excelente y no existen con las dosis aconsejadas (tabla 1) efectos secundarios de importancia. El tratamiento con GH está contraindicado en pacientes con

Síndromes y enfermedades con un riesgo incrementado de fragilidad cromosómica, tales como síndrome de Down, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi y neurofibromatosis 1.

Reevaluación del déficit de GH diagnosticado en la infancia

Antes de reconocer el déficit de GH como una enfermedad crónica, los niños solo recibían tratamiento hasta conseguir la normalización de la talla adulta. Recientemente se está comprobando que no todas las estructuras y funciones corporales dependientes de la hormona se normalizan paralelamente al crecimiento lineal. Dado que el déficit de GH podría persistir en la vida adulta y que la GH ejerce acciones metabólicas importantes, se debe reevaluar el eje GH-IGF una vez alcanzada la talla final.

Bibliografía

-

Carrascosa A, Fernández-García J, Fernández Ramos C, Ferrández Longás A, López-Siguero J, Sánchez-González E et al. Estudio transversal español de crecimiento 2008. Parte II: valores de talla, peso e índice de masa corporal desde el nacimiento a la talla adulta. *An Pediatr (Barc)*. 2008; 686:552-69.

Carrascosa A, Ferrández Longás A, Yeste D, García-Dihinx J, Romo A, Copil A et al. Estudio transversal español de crecimiento 2008. Parte I: valores de peso y longitud en recién nacidos de 26-42 semanas de edad gestacional. *An Pediatr (Barc)*. 2008; 686:544-51.

Cassorla F, Gaete X. Clasificación y valoración de la talla baja. En: Pombo M. *Tratado de Endocrinología Pediátrica*, 4.ª ed. McGraw-Hill. Interamericana. Madrid, 2009; 152-174. • Castro-Feijoo L, Pombo M. Hipopituitarismo. En: Cruz M (ed.). *Tratado de Pediatría*, 10.a ed. Ergón; 2011.

SÍNDROME METABÓLICO

Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de La Vega



Dra. Adriana Magne

Residente 1º año

Dra. Lizz D. Arrieta Serrudo

Residente 2º año

Dra. Agustina Masco

Jefa de Residentes

Sumario

Es una de las complicaciones más frecuentes del exceso de peso.

Es la adición de diversas anomalías metabólicas, cada una de las cuales es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes.

La predisposición de obesidad, la alteración en el metabolismo de la glucosa, la dislipemia y aumento de la tensión arterial, asociado a los factores de riesgo metabólico aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, aterosclerosis y diabetes.

Situación Clínica

Paciente femenina de 11 años RNT/PAEG; vacunas completas, desarrollo psicomotor normal, previamente sana acude a consulta acompañada por la madre por aumento progresivo de peso desde hace 3 años.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general; Peso: 52.300 (Pc >90) (Pz); Talla: 139 cm (Pc 50) (Pz 0/-1); CC: (Pc)TA: 100/60(Pc 5); IMC: 27 (Pc) (Pz 2/3); aumento de tejido celular subcutánea a nivel abdominal, no se evidencia signos de acantosis nigrans.

ANTECEDENTES PERSONALES: Disminución de actividad física en los últimos 3 años, cambios de domicilio continuo por alimentación rica en hidratos de carbono 6 veces por día come en la escuela,

ANTECEDENTES FAMILIARES: Padres con sobrepeso, sin antecedentes patológicos de relevancia.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: HEMOGRAMA: GB: 8.500; Hg: 4.55; Hg: 12,9; Hto: 39%; PLQ: 397.000.

QUÍMICA: G: 98; U: 25; COLT: 195; HDL: 49; LDL: 126; TG: 100.

PERFIL ENDOCRINOLÓGICO: TSH 9.33; T4L: 1.1 ECG: NORMAL.

Definición

Es una de las complicaciones más frecuentes del exceso de peso.

Es la adición de diversas anomalías metabólicas, cada una de las cuales es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes.

La predisposición de obesidad, la alteración en el metabolismo de la glucosa, la dislipemia y aumento de la tensión arterial, asociado a los factores de riesgo metabólico aumentan el ries-

go de enfermedad coronaria, aterosclerosis y diabetes 2.

Para su diagnóstico se basan en los criterios de Cook y col de los cuales se debe contar con 3 de los mismos:

- 1.- Obesidad central o abdominal. (Definida por el perímetro de cintura mayor del percentil (p) 90 para la edad y sexo). Tabla 1.
- 2.- Triglicéridos por encima de 110 mg/dl (o del p 95)
- 3.- HDL-colesterol (colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad) por debajo de 40 mg/dl (o del p 5).
- 4.- Presión arterial (ya sea la sistólica o la diastólica) mayor del p 90.
- 5.- Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (glucemia basal alterada, mayor de 100 mg/dl, o intolerancia hidrocarbonada, glucemia mayor de 140 mg/dl dos horas tras la sobrecarga oral de glucosa).

TABLA 1: Percentilos de Circunferencia de cintura según edad y sexo

Edad	Varones		Mujeres	
	Percentilos			
	50	90	50	90
5	52	59	51	57
6	54	61	53	60
7	55	61	54	64
8	59	75	58	73
9	62	77	60	73
10	64	88	63	75
11	68	90	66	83
12	70	89	67	83
13	77	95	69	94
14	73	99	69	96
15	73	99	69	88
16	77	97	68	93
17	79	90	66	86

Factores de riesgo de síndrome metabólico:

- ✓ Predisposición poligénica (genética y factores ambientales múltiples).
- ✓ Nutrición temprana (prematurez – epigenética).
- ✓ Crecimiento acelerado en etapas tempranas.
- ✓ Hijo de madre diabética o con anteceden-

te de diabetes gestacional.

- ✓ Inicio de alimentación complementaria antes de los 6 meses de edad.
- ✓ Alimentación con fórmulas lácteas durante los primeros 6 meses.
- ✓ Bajo grado de actividad física.
- ✓ Adrenarca precoz.
- ✓ Si un padre es obeso el niño presenta el doble de riesgo de presentar obesidad.
- ✓ Antecedentes familiares de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y enfermedad vascular cerebral.
- ✓ Uso excesivo de pantallas.
- ✓ Alimentación poco saludable.
- ✓ La obesidad abdominal y la resistencia insulínica son los factores predisponentes principales.

ETIOPATOGENIA

La interrelación de estos cinco criterios (obesidad abdominal, glucemia, presión arterial, triglicéridos y HDL-colesterol) que dan lugar al síndrome metabólico.

El papel de la resistencia a la insulina parece ser el responsable primordial del síndrome, se involucra en la patogénesis de la hipertensión y de la dislipemia aterogénica hablamos de resistencia a la insulina cuando la acción de esta hormona, la captación de glucosa por los tejidos periféricos y la supresión de la liberación de glucosa del hígado, se ve alterada. Para esto pueden influir factores exógenos como la obesidad, ganancia ponderal rápida, la dieta, el estrés psicosocial, la falta de sueño, la depresión. Los factores endógenos se pueden citar la raza, la pubertad, La predisposición genética, ciertos síndromes se asocian con resistencia a la insulina.

La resistencia a la insulina se asocia a la obesidad y en este caso, existen patrones clínicos que orientan su diagnóstico, como la acantosis nigricans o la distribución de grasa, que tiene importancia en el mecanismo patogénico de desarrollo de la resistencia a la insulina (a mayor circunferencia de cintura, mayor riesgo de IR).

OTRAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SÍNDROME METABÓLICO

Son las manifestaciones clínicas que no forman parte de los criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico, pero se asocian a este entre los cuales podemos mencionar:

1. Hígado graso no alcohólico (esteatosis y,

posteriormente, esteatohepatitis no alcohólica): Se presenta por la alteración de la hiperproducción de ácidos grasos por efecto del hiperinsulinismo portal. Suele ser asintomática, con elevación de dos a cinco veces de transaminasas (con predominio de GPT, salvo en estadios avanzados en los que la GOT la supera) y dos o tres veces de fosfatasa alcalina, sin aumento de bilirrubina. Puede desembocar en insuficiencia hepática por cirrosis progresiva y carcinoma.

2. Hiperandrogenismo: La insulina aumenta la producción ovárica y suprarrenal de andrógenos y disminuye los niveles de proteína transportadora de esteroides sexuales. Puede manifestarse como adrenarquia precoz en la niña e hirsutismo y oligomenorrea en la adolescente. No tiene repercusión en el varón.
3. Talla alta. La resistencia a la insulina disminuye las proteínas transportadoras de factores de crecimiento parecidos a la insulina, aumentando por tanto la IGF1 libre (factor de crecimiento insulin-like 1), principal efector de la hormona del crecimiento. Dado que el aumento de talla se acompaña de aumento de la edad ósea, la talla adulta será Normal.
4. Acantosis nigricans. Esta lesión dermatológica que afecta zonas de pliegues, sobre todo cuello y axilas, consiste en placas de hiperqueratosis con papilomatosis y pigmentación. Existe controversia sobre si es secundaria a la resistencia a la insulina o a la obesidad y el sobrepeso, pues se puede encontrar en individuos con exceso de peso insulino sensibles.

Abordaje de niños y adolescentes con síndrome metabólico

Es importante la prevención y la detección temprana de los pacientes de riesgo. El tratamiento de la obesidad en la infancia es la prevención de la obesidad del adulto. El objetivo primordial es promover un estilo de vida saludable.

Se debe tratar de lograr una alianza adecuada con el niño y su familia centrada en la importancia del tratamiento. La entrevista motivacional es un método centrado en el paciente con el objetivo de incentivar sus propias motivaciones

al cambio y plantear sus objetivos. Al ser una patología crónica, su enfoque interdisciplinario con respecto a la terapéutica y al diagnóstico de complicaciones es de fundamental importancia. La atención debe ser multidisciplinaria, pero se sugiere que como pediatra se debe:

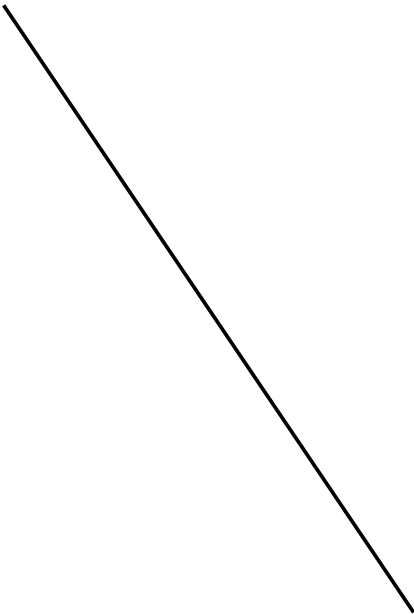
- Evaluación antropométrica inicial.
- IMC $\geq$ al percentilo 85.
- Determinar circunferencia de cintura
- Evaluación de antecedentes familiares
- Examen clínico completo buscando manifestaciones de resistencia a la insulina.
- Determinar TA.
- Exámenes de laboratorio: Glucemia e insulina basal, glucemia e insulina 2 hs postcarga de glucosa.
- Perfil lipídico completo.
- Hepatograma.
- Ácido úrico.
- Microalbuminuria.
- Ecografía hepática (en la búsqueda de esteatosis).

DISCUSIÓN:

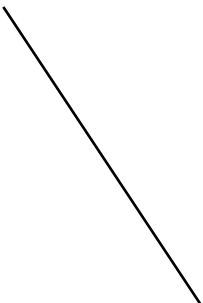
CRITERIOS	CONSENSO SAP 2010	PACIENTE
TRIGLICÉRIDOS (mg/dl)	> 110	100
HDL (mg/dl)	< 40	49
CC	< P 90	
GLUCEMIA (mg/dl)	> 100	98
PRESIÓN ARTERIAL	> P 90	

Bibliografía

- Comité Nacional de Nutrición. Obesidad: guías para su abordaje clínico
- Ferraro M. Síndrome metabólico: Cuando la obesidad "enferma" al metabolismo. Servicio de Nutrición y Diabetes. Hospital Pedro de Elizalde - Jornadas Nacionales del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría
- García García E. Obesidad y síndrome metabólico en pediatría- 12º curso de actualización pediatría 2015.
- Setton D, P Sosa. Gastroenterología, Hepatología y Nutrición.



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **G**

¿POR QUÉ NO PENSAR EN CARDIOPATÍAS?

**Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.
Servicio de Pediatría.**



Dra. María Martha Rottini

Jefa de Servicio

Dra. Silvina Rocha

Jefa de Sala e Instructora

Dra. Carla Abud

Dra. Elena Vicente

Dra. Juliana Safar

Dra. Yanina Baibona

Dra. Gina Batistelli

Dr. Ari Santucho

Residentes

Dr. Carlos Gabriel Dinatale*

Revisor

Dra. María Eugenia Olivetti**

Revisora

Sumario

La incidencia de CC se estima en 0,8 a 1%, en todo el mundo, independientemente de la condición socioeconómica, raza o situación geográfica. Alrededor del 70% requiere cirugía cardíaca en algún momento de su evolución. Un 40% se enfermará críticamente y fallecerá antes del año a menos que reciba el tratamiento oportuno correspondiente. De los que mueren, sólo el 30% llegan a ser examinados por un cardiólogo infantil.

El diagnóstico precoz es fundamental para lograr el tratamiento exitoso de una CC.

Situación clínica

Faustino, de 2 meses y 11 días de edad, sin antecedentes de jerarquía, ingresó a sala de pediatría por cuadro de 4 días de evolución caracterizado por quejido espiratorio y astenia.

Al examen físico se presentó en regular estado general, hemodinámicamente inestable, normohidratado, mal perfundido, con palidez cutá-

nea, taquicárdico, taquipneico, saturando 86% O₂ aire ambiente, normotenso, con un peso de 4,4 kg. Con buena entrada bilateral de aire, con aislados roncos y mecánica ventilatoria exigida. A la auscultación cardiovascular presentó tercer ruido, soplo sistólico por hiperflujo en base, pulsos conservados y relleno capilar enlentecido. Hígado a 2 cm del reborde costal.

Se solicitó radiografía de tórax con índice cardiorácico conservado y leve infiltrado bilateral, y laboratorio con leve leucocitosis a predominio neutrofílico, trombocitosis, normoglucemia, función renal conservada y PCR normal.

Se indicó hidratación parenteral y oxigenoterapia continuando con hipoxemia, por lo que pasa a UTIP.

Reflexiones

¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales?

¿Qué estudios se solicitarían?

¿Cuál sería la conducta a tomar?

Por sospecha de cardiopatía congénita, es eva-

luado por cardiólogo infantil quien informa: precordio ligeramente activo, soplo sistólico de hiperflujo pulmonar, R3 intermitente, SatO2 90% con máscara con reservorio, radiografía de tórax con cardiomegalia leve. Realizó ecodoppler cardíaco: situs solitus, concordancia A-V/V-A, retorno venoso sistémico en aurícula derecha (AD), ausencia de retorno venoso en aurícula izquierda (AI). Vena pulmonar común, colector retroauricular que asciende, pero desemboca con buen calibre a flujo de vena cava superior (VCS). Colector de buen calibre, no estrecho, dilatación de AD, ventrículo derecho (VD) y vena pulmonar (VP), hiperflujo pulmonar, comunicación interauricular (CIA) amplia, buena función biventricular.

Se diagnostica anomalía total del retorno venoso pulmonar supracardíaca (ATRV), se deriva a centro tratante donde se realiza cirugía correctora.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (CC)

Se define como cardiopatía congénita (CC) a toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos, consecuencia de las alteraciones del desarrollo embrionario del corazón, aproximadamente entre la 3ª y 10ª semana de gestación.

La incidencia de CC se estima en 0,8 a 1%, en todo el mundo, independientemente de la condición socioeconómica, raza o situación geográfica. Alrededor del 70% requiere cirugía cardíaca en algún momento de su evolución. Un 40% se enfermará críticamente y fallecerá antes del año a menos que reciba el tratamiento oportuno correspondiente. De los que mueren, sólo el 30% llegan a ser examinados por un cardiólogo infantil.

Las CC pueden tener una causa genética, ambiental o multifactorial. Es fundamental recabar antecedentes maternos como amenaza de aborto, exposición a teratógenos, ingesta de alcohol, tiempo de gestación, enfermedades y, sobre todo, cardiopatía congénita materna (que aumenta la incidencia en un 15%).

El diagnóstico precoz es fundamental para lograr el tratamiento exitoso de una CC. La forma de presentación de una cardiopatía congénita depende fundamentalmente del tipo y la gravedad de la lesión cardíaca, la complacencia de las cavidades, la caída de las resistencias pulmo-

nares y el cierre del ductus arterioso. Los signos sospechosos de CC en el RN son cianosis, taquipnea, presencia de soplo y alteración de los pulsos.

CLASIFICACIÓN Y FISIOPATOLÓGICA

ACIANÓTICAS

Corto circuito izquierda-derecha, con flujo pulmonar aumentado: CIA-CIV-DAP-CANAL AV

Obstructivas o valvulopatías, con flujo pulmonar normal: CoAo-EAo-EP

Miocardopatías, con flujo pulmonar normal.

CIANÓTICAS

Corto circuito derecha-izquierda: Tetralogía de Fallot

Fisiología de circulación en paralelo: D-TGV

Mezcla obligada: ATRVP-AT-AP-SCIH, VU

CARDIOPATÍAS ACIANÓTICAS

Se clasifican de acuerdo a la sobrecarga fisiológica que imponen al corazón. Las más frecuentes son aquellas que producen sobrecarga de volumen, y, en segundo lugar, se encuentran las que producen sobrecarga de presión.

CORTOCIRCUITO IZQUIERDA – DERECHA (con flujo pulmonar aumentado)

Como generalidad, la clínica de este tipo de cortocircuito depende del tamaño del defecto y del balance entre el flujo sistémico y el flujo pulmonar. Los defectos pequeños presentan soplo sin signos de insuficiencia cardíaca congestiva. El diagnóstico definitivo se realiza con el ecocardiograma doppler, en donde se visualiza el detalle anatómico cardíaco, el tipo y el tamaño del defecto, presencia o ausencia de signos de hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia, la función cardíaca, etc.

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)

Pueden localizarse en cualquier parte del tabique interauricular. Su incidencia global es del 10% de todas las CC.

CLÍNICA: Presenta soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar con irradiación a dorso, R2 desdoblado fijo y R3 patológico raro. Puede presentar formas asintomáticas y formas con detención pondoestatural.

DIAGNÓSTICO: Rx de tórax con cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas y flujo sanguíneo pulmonar aumentado. ECG con sobrecarga de AD y VD (P pulmonar, PR prolongado, eje QRS normal o desviado a la derecha, BCRD). El ecocardiograma muestra hallazgos

característicos de sobrecarga de volumen del VD, con un aumento del diámetro telediastólico del VD y aplanamiento y movimiento anómalo del tabique interventricular.

PRONÓSTICO: Las CIA detectadas en lactantes a término pueden cerrarse de forma espontánea.

TRATAMIENTO: Cirugía o cierre con dispositivos liberados por catéter en todos los pacientes sintomáticos. La cirugía programada suele realizarse tras el primer año de vida y antes de iniciar el período escolar.

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV)

Es la malformación cardíaca más frecuente con una incidencia global del 25%. Los defectos pueden alojarse en cualquier zona del tabique interventricular.

CLÍNICA: Presenta soplo sistólico regurgitativo, mesocárdico que irradia a todos los focos y R3 patológico. Puede ir desde formas asintomáticas hasta disnea, dificultad en la alimentación, crecimiento insuficiente, sudoración profusa, infecciones pulmonares recurrentes e insuficiencia cardíaca.

DIAGNÓSTICO: La Rx de tórax puede ser normal o presentar cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas con flujo sanguíneo pulmonar aumentado. El ECG suele ser normal o presentar hallazgos de sobrecarga de AI y VI (P mitral, eje QRS con desviación a la izquierda, progresión izquierda en precordiales, HBAI). El ecocardiograma muestra la posición y el tama-



ño de la CIV.

PRONÓSTICO: Su curso natural depende del tamaño del defecto. Las CIV pequeñas suelen cerrarse de forma espontánea antes de los 4 años. Los niños con CIV de gran tamaño corren el riesgo de desarrollar con el tiempo una enfermedad vascular pulmonar e insuficiencia valvular aórtica.

TRATAMIENTO: No se recomienda la reparación quirúrgica en CIV de pequeño tamaño, sólo se debe realizar protección contra endocarditis infecciosa. Está indicado el cierre quirúrgico en aquellos pacientes con defectos grandes en los que no se pueden controlar con tratamiento médico los síntomas clínicos y el retraso del crecimiento.

DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE (DAP)

El cierre funcional del conducto arterioso suele ocurrir poco después del nacimiento. Su permeabilidad se asocia en un 10% a otras cardiopatías y presenta una incidencia global del 15%.

CLÍNICA: Presenta soplo continuo o sistólico en base, con pulsos saltones y presión diferencial amplia con R3 patológico. El ductus permeable pequeño suele ser asintomático, cuando es de mayor tamaño produce insuficiencia cardíaca y retraso del crecimiento.

DIAGNÓSTICO: La Rx de tórax puede mostrar arterias pulmonares prominentes con aumento de la vascularización pulmonar, e índice cardiotorácico normal o con ligera cardiomegalia, el botón aórtico se puede ver normal o prominente. El ECG es normal y en algunos casos pueden observarse signos de sobrecarga de cavidades izquierdas. En el ecocardiograma la imagen de las cámaras cardíacas es normal en los conductos pequeños; en los grandes, la AI y el VI se encuentran aumentados de tamaño.

PRONÓSTICO: Los pacientes con DAP pequeño pueden tener una esperanza de vida normal, el cierre del ductus después de la lactancia es infrecuente. Ante un DAP de gran tamaño se suele desarrollar insuficiencia cardíaca y puede producir endocarditis infecciosa a cualquier edad.

TRATAMIENTO: independientemente de la edad, requieren cierre quirúrgico o con cateterismo.

COMUNICACIÓN AURICULOVENTRICULAR (CAV)

Se presenta un defecto del tabique auriculo-

ventricular (ostium primum y defecto de los cojinetes endocárdicos)

CLÍNICA: En general son asintomáticos. A la auscultación se halla un primer ruido normal o acentuado, un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, un soplo sistólico de eyección pulmonar, y un retumbo mesodiastólico en el borde esternal izquierdo inferior o en el vértice. Puede aparecer insuficiencia cardíaca e infecciones intercurrentes durante la lactancia, hepatomegalia y retraso del crecimiento.

DIAGNÓSTICO: La Rx de tórax muestra notable cardiomegalia, arteria pulmonar prominente y trama vascular pulmonar aumentada. El ECG se caracteriza por orientación del eje hacia los cuadrantes superiores, signos de hipertrofia biventricular, retraso en la conducción del ventrículo derecho y prolongación ocasional del intervalo PR. El ecocardiograma muestra signos de aumento de tamaño del ventrículo derecho con superposición de los ecos de la válvula mitral en el tracto de salida del ventrículo izquierdo

PRONÓSTICO: La mayoría de los pacientes con comunicaciones mínimas se encuentran asintomáticos o presentan síntomas menores que no progresan hasta la tercera o cuarta década de vida. Ante la ausencia de cirugía correctora presentan una alta mortalidad.

TRATAMIENTO: La intervención quirúrgica debe llevarse a cabo durante la lactancia. Las comunicaciones se cierran mediante parches y se reconstituyen las válvulas AV.

OBSTRUCTIVAS O VALVULOPATÍAS (con flujo pulmonar normal)

COARTACIÓN AÓRTICA (CoAo)

La zona de coartación puede localizarse desde el cayado aórtico hasta la bifurcación aórtica, el 98% aparece por debajo del origen de la arteria subclavia izquierda a la altura del origen del conducto arterioso. La incidencia global es del 5%.

CLÍNICA: Presenta soplo sistólico eyectivo en zona interescapular izquierda, con pulsos femorales ausentes o disminuidos, hipertensión en MMSS con baja presión en MMII. Cuando son diagnosticadas después de la lactancia rara vez se manifiestan con síntomas significativos. Los recién nacidos manifiestan signos de shock inminentes tras el cierre del ductus arterioso.

DIAGNÓSTICO: Los hallazgos radiológicos dependen de la edad del paciente y de los efectos de la hipertensión y de la circulación colateral.

Se puede visualizar cardiomegalia y congestión pulmonar. El ECG presenta signos de sobrecarga de AI y VI, suele ser normal en los niños pequeños. El ecocardiograma doppler es el método de elección para confirmar el diagnóstico.

TRATAMIENTO: Los pacientes con debut neonatal de CoAo grave deben recibir una perfusión de prostaglandina E1 para mantener permeable el conducto arterioso y restablecer el adecuado flujo sanguíneo a los MMII. Tras el diagnóstico, la reparación quirúrgica debe hacerse precozmente. En niños mayores con hipertensión arterial y/o pulsos débiles o ausentes, el tratamiento hemodinámico con colocación de stent vs. cirugía reparadora, siguen siendo los métodos de elección.

ESTENOSIS AÓRTICA (EAO)

Presenta una incidencia global del 4%. En su forma más frecuente, se observa engrosamiento de las valvas y fusión variable de las comisuras de la válvula aórtica.

CLÍNICA: Presenta soplo sistólico eyectivo en foco aórtico con irradiación a dorso. La sintomatología depende de la gravedad de la obstrucción. La mayoría de los niños con formas menos graves de EAO permanecen asintomáticos con crecimiento y desarrollo normales. En raras ocasiones aparece fatiga, ángor, mareo o síncope en niños mayores.

DIAGNÓSTICO: La radiografía presenta dilatación del arco aórtico con botón aórtico normal, agrandamiento del VI, flujo sanguíneo pulmonar conservado o levemente aumentado. Si el gradiente de presión a través de la válvula aórtica es leve, el ECG será normal. Si la estenosis es de larga duración, existen signos de hipertrofia y sobrecarga del VI. El ecocardiograma doppler permite identificar la localización y la gravedad de la obstrucción.

PRONÓSTICO: Los neonatos con estenosis crítica pueden presentar shock con bajo gasto cardíaco. En lactantes mayores y en niños con formas leves o moderadas, el pronóstico es razonablemente bueno. Es frecuente que la enfermedad progrese en el plazo de 5 – 10 años. Se requiere profilaxis de endocarditis de por vida.

TRATAMIENTO: En las EAO moderadas o graves está indicada la valvuloplastia con balón. Después del periodo neonatal, en los que no es posible este tipo de tratamiento, debe indicarse la reparación quirúrgica.

ESTENOSIS PULMONAR (EP)

Presenta una incidencia global del 10%.

CLÍNICA: Presenta soplo sistólico eyectivo pulmonar, con desdoblamiento del segundo ruido. Las EP leves o moderadas suelen ser asintomáticas. Si es grave, pueden existir signos de insuficiencia ventricular derecha.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax se visualiza una arteria pulmonar saliente, con flujo sanguíneo pulmonar conservado sin cardiomegalia. El ECG muestra signos de sobrecarga de cavidades derechas por hipertrofia de ventrículo derecho. El ecocardiograma doppler muestra hipertrofia del ventrículo derecho.

PRONÓSTICO: Sólo se produce insuficiencia cardíaca en los casos graves. Durante la infancia no es frecuente la endocarditis infecciosa. Los niños con formas leves pueden llevar una vida normal.

TRATAMIENTO: Se debe tratar a todos los pacientes con EP moderadas o graves para aliviar la obstrucción.

MIOCARDIOPATÍAS

(con flujo pulmonar normal)

MIOCARDIOPATÍA DILATADA

Se caracteriza por presentar cardiomegalia secundaria a la gran dilatación de los ventrículos. Su causa se desconoce, pero podría ser genética.

CLÍNICA: Afecta a cualquier grupo etario. Tiene un inicio insidioso. Son frecuentes la irritabilidad, la anorexia, el dolor abdominal, la tos debida a la congestión pulmonar y la disnea de esfuerzo. Los lactantes y niños pequeños tienden a mostrar síntomas respiratorios y retraso del crecimiento. Cuando la enfermedad está totalmente establecida, hay cardiomegalia y puede existir un soplo holosistólico de insuficiencia mitral o triscupídea.

DIAGNÓSTICO: La Rx de tórax confirma la cardiomegalia. El ECG muestra aumento del tamaño auricular, grados de hipertrofia ventricular y anomalías inespecíficas de la onda T. El ecocardiograma doppler presenta dilatación de la AI y el VI con mala contractibilidad.

PRONÓSTICO: El curso de la enfermedad suele tener un deterioro progresivo.

TRATAMIENTO: Debe proveerse tratamiento médico sintomático y, si éste fracasa, debe evaluarse el trasplante cardíaco.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

Pueden ser secundarias a la presencia de cardiopatías congénitas obstructivas o a errores congénitos del metabolismo o bien, idiopáticas. Se presentan a cualquier edad y casi siempre con un patrón de herencia autosómico dominante.

CLÍNICA: La mayoría son asintomáticos, y alrededor del 50% se estudian por primera vez a causa de un soplo o de otro miembro de la familia afectado. Se caracteriza por debilidad, cansancio, disnea de esfuerzo, palpitaciones, ángor, mareos y síncope. El soplo sistólico es de tipo eyectivo y de intensidad intermedia.

DIAGNÓSTICO: La Rx de tórax muestra leve cardiomegalia con prominencia del VI. El ECG muestra hipertrofia del VI con o sin depresión del segmento ST e inversión de las ondas T.

PRONÓSTICO: Es una CC impredecible, los pacientes asintomáticos pueden permanecer estables durante años. Algunos evolucionan hacia la insuficiencia cardíaca, otros corren el riesgo de muerte súbita por una arritmia.

TRATAMIENTO: En las que son resultado de una patología obstructiva, están indicados los bloqueantes cálcicos y antagonistas beta para evitar los eventos arrítmicos. La resección quirúrgica del músculo hipertrofiado disminuye el riesgo de arritmias fatales y permite la mejoría clínica. El trasplante cardíaco es el tratamiento definitivo para los casos severos refractarios.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

La principal alteración de esta CC, es la mala distensibilidad ventricular.

CLÍNICA: Cuando alcanza su máxima expresión produce disnea, edemas, ascitis, hepatomegalia, aumento de la presión venosa y congestión pulmonar. El corazón presenta un aumento de tamaño y pueden auscultarse soplos inespecíficos.

DIAGNÓSTICO: El ECG muestra ondas P muy prominentes, complejos QRS de voltajes normales, depresión del segmento ST y ondas T invertidas. Se observa cardiomegalia en la Rx de tórax y un notable aumento de las aurículas con ventrículos de tamaño normal o pequeño con función sistólica a menudo preservada en el ecocardiograma doppler. Pueden ser idiopáticas o asociarse a enfermedades sistémicas. Es esencial realizar el diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva, ya que ésta tiene un

tratamiento quirúrgico.

PRONÓSTICO: Presentan un mal pronóstico y el deterioro clínico puede ser rápido.

TRATAMIENTO: El tratamiento busca el alivio de la insuficiencia cardíaca.

CARDIOPATÍAS CIANÓTICAS

Las cardiopatías congénitas producen cianosis cuando la obstrucción del tracto de salida del VD da lugar a cortocircuitos de derecha a izquierda o cuando existen defectos anatómicos complejos, no asociados con EP, que provocan una mezcla de sangre precedente del retorno venoso pulmonar y sistémico en el corazón.

Aunque la presencia de un soplo significativo suele sugerir un origen cardíaco de la cianosis, al principio muchas de las cardiopatías más graves no lo presentan. La Rx de tórax puede ser útil para diferenciar entre enfermedades pulmonares y cardiopatías; en estas últimas, indica si el flujo sanguíneo está aumentado, normal o disminuido.

Podemos clasificarlas en tres grupos:

Cortocircuito de derecha a izquierda: Tetralogía de Fallot

Fisiología de circulación en paralelo: TGV

Fisiología de ventrículo único: AP, AT, VU, ATR-VP, SCIH

A su vez, éstas se pueden clasificar en:

CC con hipoflujo pulmonar

CC con hiperflujo pulmonar

CARDIOPATÍAS CIANÓTICAS CON HIPOFLUJO PULMONAR

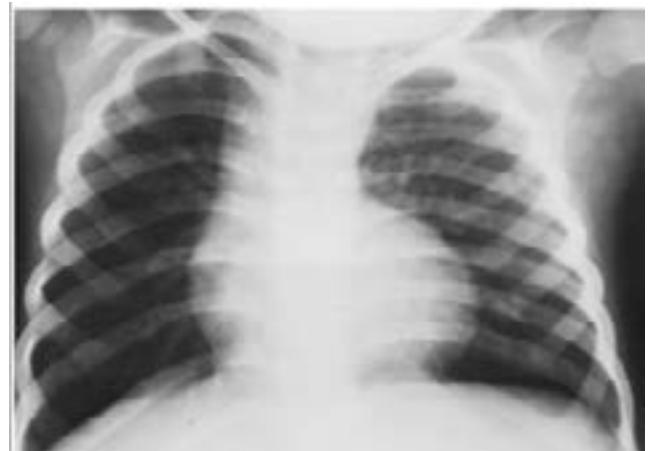
Tetralogía de Fallot

Se caracteriza por las siguientes alteraciones: Obstrucción del tracto de salida del VD, CIV, cabalgamiento de la aorta sobre el tabique e hipertrofia VI. La atresia pulmonar total mas CIV se clasifica como tetralogía de Fallot extrema.

CLÍNICA: Con la hipertrofia y el crecimiento del paciente, se manifiesta la cianosis durante el primer año de vida. A veces en formas graves es inmediata, en general es en el lecho ungueal y peribucal. En niños mayores puede haber disnea y posición en cuclillas. Los ataques cianóticos paroxísticos son frecuentes los dos primeros años de vida y pueden generar hipoxia. El crecimiento y el desarrollo pueden retrasarse en los casos graves, también la pubertad. Se puede palpar un impulso ventricular derecho supraesternal y frémito sistólico.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax, se observa concavidad del borde cardíaco izquierdo, corazón “en bota” o “en sueco” y aorta aumentada de tamaño. En el ECG, el eje se desvía a la derecha y hay signos de hipertrofia derecha. Onda R dominante, onda T positiva en V3 y V1 y onda P picuda. El ecocardiograma establece el diagnóstico y determina el grado de obstrucción. La presión de salida de la arteria pulmonar suele ser más baja de lo normal.

TRATAMIENTO: Los casos graves requieren tratamiento médico y luego resolución quirúrgica; la prostaglandina permite mantener el flujo hasta la resolución en los casos graves.



Atresia pulmonar con tabique interventricular íntegro

Las valvas de la válvula pulmonar están fusionadas y forman una membrana. El tracto de salida del VD es atrésico. Al no haber CIV, la sangre no fluye y la presión en la AD aumenta. La sangre desvía por el agujero oval hacia la izquierda y se mezcla con el retorno venoso, y luego entra en el VI. Se asocia a VI hipoplásico e insuficiencia tricuspídea.

CLÍNICA: Si el conducto arterioso se cierra las primeras horas de vida, se desarrolla una intensa cianosis con dificultad respiratoria, con ruido cardíaco único y fuerte.

PRONÓSTICO: Sin tratamiento hay una alta mortalidad.

DIAGNÓSTICO: En el ECG se observa onda P picuda y QRS de menor voltaje. En la Rx de tórax aparece disminución de la trama vascular pulmonar. En el ecocardiograma se pueden evidenciar los canales sinusoidales si éstos son grandes.

TRATAMIENTO: Prostaglandina E hasta la co-

rección quirúrgica.

Atresia tricuspídea

No existe salida desde la AD hacia el VD, el retorno venoso ingresa al lado izquierdo por el agujero oval. Esta misma suele pasar a ventrículo derecho por una CIV.

CLÍNICA: Cianosis desde el nacimiento, impulso apical llamativo. Soplos audibles en región paraesternal izquierda. En las más grandes, cianosis, fatiga y disnea.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax, se aprecia disminución de la trama vascular pulmonar. En el ECG, desviación del eje hacia la izquierda. En el ecocardiograma, VD de pequeño tamaño, VI y aorta grandes, membrana fibromuscular en el lugar de la válvula tricuspídea.

TRATAMIENTO: Infusión de prostaglandinas en los neonatos hasta la cirugía.

VD de doble salida con EP

Nacimiento tanto de la aorta como de la arteria pulmonar en el VD. La salida desde el VI es una CIV que comunica al mismo con el derecho. La aorta puede cabalgar sobre la CIV.

DIAGNÓSTICO: El ecocardiograma muestra grandes vasos que nacen del VD y discontinuidad entre válvula mitral y aórtica.

TRATAMIENTO: Cirugía correctora.

Transposición de grandes arterias más CIV más estenosis pulmonar

Se trata de una alteración similar a Fallot, pero la obstrucción se encuentra en VI.

CLÍNICA: En el neonato o hacia el final de la lactancia, aparece cianosis; en los niños mayores, disminución de la tolerancia al ejercicio. En el ECG se ven signos de hipertrofia derecha e izquierda. En el ecocardiograma se puede evaluar el grado de obstrucción del tracto de salida del VI.

TRATAMIENTO: Infusión con prostaglandina E y quirúrgico.

Anomalía de Ebstein de la válvula tricuspídea

Hay un desplazamiento inferior de la válvula tricuspídea anómala hacia el VD. La válvula divide al VD en dos partes. Una zona de paredes delgadas que se continúa con la AD y otra de miocardio normal. El gasto se ve afectado por el grado de obstrucción e insuficiencia valvular.

CLÍNICA: Variable de acuerdo al desplazamiento de la válvula tricuspídea. Palpitaciones, fatiga, arritmias. Cianosis y policitemia. Sopro generado por la insuficiencia valvular. Ruido pericárdico y ritmo de galope.

DIAGNÓSTICO: En el ECG, bloqueo de rama derecha. La Rx de tórax evidencia corazón normal o cardiomegalia. El ecocardiograma muestra desplazamiento de válvula tricuspídea, AD dilatada y obstrucción del tracto de salida del VD. En la ecografía doppler, se ve insuficiencia valvular.

TRATAMIENTO: Cirugía correctora.

CARDIOPATÍAS CIANÓTICAS CON HIPERFLUJO PULMONAR

Transposición de las grandes arterias

La aorta nace del VD, y la arteria pulmonar, del VI. La sangre desaturada que retorna de todo el organismo al hemicardio derecho se dirige inapropiada y directamente a la aorta y regresa al organismo, mientras que la sangre oxigenada del retorno venoso pulmonar que llega al hemicardio izquierdo vuelve directamente a los pulmones. La supervivencia en estos recién nacidos depende del agujero oval y del conducto arterioso que permite que se produzca algo de mezcla entre la sangre oxigenada y la desoxigenada.

Las manifestaciones clínicas y hemodinámicas dependen de la presencia o ausencia de defectos asociados.

Supone el 5 % de todas las CC. Es más frecuente en lactantes de madres diabéticas y en niños (3:1).

Antes de la era moderna de la cirugía correctora o paliativa, la mortalidad sobrepasaba el 90% en el primer año de vida.

Transposición de las grandes arterias con tabique interventricular íntegro

Antes del nacimiento, la oxigenación del feto es casi normal. Pero tras el nacimiento, una vez que el conducto comienza a cerrarse, la mínima mezcla de sangre pulmonar y sistémica a través del agujero oval permeable suele ser insuficiente por lo que se produce una hipoxemia grave, por lo general en los primeros días de vida.

CLÍNICA: Cianosis y taquipnea. No siempre se escuchan soplos.

DIAGNÓSTICO: En el ECG se puede observar patrón dominante del corazón derecho. La Rx de tórax muestra leve cardiomegalia, mediastino estrecho y flujo pulmonar aumentado. En el ecocardiograma hay conexiones traspuestas. La mezcla puede observarse con doppler color. Se realiza cateterismo ante duda; muestra que la presión de VD es sistémica.

TRATAMIENTO: prostaglandina E1 para mantener permeable el conducto arterioso y mejorar la oxigenación. Tratamiento quirúrgico en la segunda semana de vida.

PRONÓSTICO: Sin tratamiento, no hay supervivencia.

TRANSPOSICIÓN DE LAS GRANDES ARTERIAS CON CIV ASOCIADA

CLÍNICA: Las manifestaciones y hallazgos son similares a la anterior, se escucha un soplo sistólico en borde esternal izquierdo. Con CIV grandes pueden devenir manifestaciones de ICC. La cianosis suele verse el primer mes de vida en estos casos.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax se observa cardiomegalia; en el ECG, ondas P prominentes e hipertrofia de VD. En el ecocardiograma se puede medir el flujo en AI y VI. Se puede realizar cateterismo en casos dudosos.

TRATAMIENTO: Quirúrgico tan pronto se realice el diagnóstico.

PRONÓSTICO: Sin tratamiento tienen una alta tasa de mortalidad el primer mes de vida.

TRANSPOSICIÓN DE LAS GRANDES ARTERIAS

Se trata de conexiones AV discordantes. Las grandes arterias también están transpuestas, la sangre venosa pasa a la AD, desde allí al VD; la sangre bombeada desde el VI pasa a la arteria pulmonar y a los pulmones. La sangre allí regresa a AI y luego hacia VI y es bombeada hacia la aorta. La circulación está fisiológicamente corregida. Pero en general se asocia a otros defectos. (CIV, estenosis pulmonar valvular)

CLÍNICA: si no hay obstrucción al tracto de salida pulmonar, los síntomas son similares a CIV aislada. Si se asocia a estenosis y CIV, los síntomas son similares a Fallot.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax, la aorta ocupa el borde superior izquierdo de la silueta cardíaca. El ECG muestra onda P anómala, onda T positiva en derivaciones precordiales, hay ausencia de onda Q en V6 u onda Q anómala en D3, AVr, AVf y V1.

TRATAMIENTO: Quirúrgico.

VD DE DOBLE SALIDA SIN ESTENOSIS PULMONAR

Tanto la aorta como la arteria pulmonar nacen del VD. La única salida del VI es una CIV.

CLÍNICA: es similar a una CIV no complicada, aunque puede haber hipoxemia por la mezcla en VD.

DIAGNÓSTICO: En el ECG se ven signos de hipertrofia biventricular. El ecocardiograma muestra el origen de ambas arterias en VD. El cateterismo demuestra que la sangre bombeada por el VI se dirige directamente a la circulación sistémica.

TRATAMIENTO: quirúrgico.

VD DE DOBLE SALIDA CON TRANSPOSICIÓN DE LAS GRANDES ARTERIAS

Es una CIV supraventricular, subpulmonar.

CLÍNICA: IC en etapas precoces. Soplo sistólico paraesternal eyectivo. Son frecuentes las obstrucciones eyectivas izquierdas.

DIAGNÓSTICO: En el ECG, signos de hipertrofia izquierda o biventricular. En la Rx de tórax aparece cardiomegalia.

TRATAMIENTO: cerclaje de arteria pulmonar, corrección definitiva en niños mayores.

RETORNO VENOSO PULMONAR ANÓMALO COMPLETO

Tiene varias formas. Las venas pulmonares pueden drenar en la AD, en la VCS o, a través de una vena descendente, unirse a la VCI.

CLÍNICA: Puede haber cianosis de intensidad variable, taquipnea, soplo e IC precoz.

DIAGNÓSTICO: En el ECG, signos de hipertrofia ventricular derecha; en la Rx de tórax, gran sombra paracardíaca (aspecto de “muñeco de nieve”); en el ecocardiograma, hay presencia de un gran VD y se puede demostrar la presencia de un vaso abdominal con flujo doppler venoso que se aleja del corazón; por cateterismo, la saturación de oxígeno es similar en todas las cámaras cardíacas: cardiopatía con mezcla completa.

TRATAMIENTO: En lactantes, corrección quirúrgica, previa estabilización con prostaglandinas E1 para dilatar conductos venoso y arterioso.

TRONCO ARTERIOSO

Un único tronco arterial nace del corazón y nutre las circulaciones sistémica, pulmonar y coronaria. Siempre hay CIV y el conducto de encuentra sobre la comunicación por lo que recibe sangre de ambos ventrículos.

CLÍNICA: Al comienzo, se manifiesta con un

soplo y mínima cianosis. Luego predomina la insuficiencia cardíaca. En niños mayores puede haber, por la enfermedad vascular pulmonar obstructiva, cianosis progresiva, dedos en palillo de tambor y policitemia.

DIAGNÓSTICO: En el ECG, signos de hipertrofia ventricular izquierda, derecha o combinada. En la Rx de tórax, se aprecia cardiomegalia. En cuanto al ecocardiograma, muestra una gran arteria truncal que cabalga sobre la CIV. Por cateterismo se puede ver un cortocircuito ventricular de izquierda a derecha y un cortocircuito de derecha a izquierda en el tronco arterioso.

TRATAMIENTO: Fármacos anticongestivos y cirugía.

VENTRICULO ÚNICO (VU)

Ambas aurículas vacían la sangre en una única cámara ventricular. La aorta y la pulmonar nacen de esta única cámara. Son frecuentes la atresia o estenosis pulmonar.

CLÍNICA: Si hay obstrucción al tracto de salida pulmonar, similar a Fallot, sin IC. Si no hay obstrucción, los hallazgos son similares a los de la CIV, con trasposición y cianosis leve con IC. Puede haber soplo sistólico eyectivo, chasquido y segundo ruido de intensidad alta, cianosis, dedos en palillo de tambor, disnea y retraso del crecimiento.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax, se observa cardiomegalia. Los signos en el ECG son inespecíficos. En el ecocardiograma, se evidencia ausencia de tabique interventricular.

TRATAMIENTO: Quirúrgico.

SÍNDROME DE CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO

Falta de desarrollo del ventrículo izquierdo (atresia de orificio aórtico o mitral). Inadecuado mantenimiento de la circulación sistémica e hiperflujo pulmonar.

CLÍNICA: Cianosis, hipoperfusión y shock, con previos signos de IC. Pulsos débiles o ausentes, soplo anodino sistólico.

DIAGNÓSTICO: En la Rx de tórax hay cardiomegalia e hiperflujo pulmonar. En el ECG, ondas P prominentes. En el ecocardiograma se confir-

ma la hipoplasia.

TRATAMIENTO: Quirúrgico.

PRONÓSTICO: Sin corrección quirúrgica, hay una alta tasa de mortalidad en las primeras semanas de vida.

Reflexión final del Experto

Las CC siguen siendo una entidad con importante morbimortalidad a nivel mundial.

Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en los métodos de diagnóstico y en las técnicas de reparación quirúrgica de muchos defectos estructurales cardíacos, la historia clínica personal y familiar, la semiología cardíaca, la radiografía de tórax y el electrocardiograma siguen siendo herramientas fundamentales para el médico pediatra, neonatólogo, intensivista, generalista, etc.

De esta manera, el rol del clínico pediatra adopta una postura muy importante. Es el eslabón primordial en la sospecha de estos defectos y para que los pacientes sean derivados al especialista en tiempo y forma.

En CC debemos ser precoces y correctores, para que nuestros niños tengan la mejor calidad de vida.

Bibliografía

- Allen, Hugh D., Shaddy, Robert E., Penny, Daniel J., Feltes, Tomothy F., Cetta, Frank (2016): *Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, Including the Fetus and Young Adult*. 9na Edición. Inglaterra: Walters Kluwer.
- Nelson, Kliegman, Stanton, St. Geme, Schor (2016): *Tratado de pediatría*. 20ª Edición. España: Elsevier.
- Park, K. Myung (2015): *Cardiología pediátrica*. 6ta Edición. España: Elsevier.
- Somoza, F., Marino, B., Romero, S. (2016): *Cardiopatías congénitas. Cardiología perinatal*. 2da Edición. Argentina: Journal.

***Dr. Carlos Gabriel Dinatale**

Cardiólogo pediatra.

****Dra. María Eugenia Olivetti**

Cardióloga Infantil.

CARDIOPATÍAS ASOCIADAS A SÍNDROMES POLIMALFORMATIVOS Y A ENFERMEDADES SISTÉMICAS

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Clínica Pediatría



Dra. Paola Basualdo

Instructora de Residentes

Dra. Mariangeles Cura

Dra. María Laura Andornino

Dra. Ana Belén Solillo

Dra. Natalia Dadiago

Residentes

Dra. Rebeca Flores

Concurrente

Dr. Cristian Sánchez Vocci*

Revisor

Sumario

Las cardiopatías congénitas tienen una incidencia importante. Se presentan dos casos clínicos y se revisa la bibliografía.

El primer caso es un síndrome de Noonan típico. Se revisan otros síndromes genéticos con sus Cardiopatías asociadas.

El segundo caso es un niño con enfermedad de Kawasaki en la cual el diagnóstico precoz puede evitar las alteraciones coronarias.

SITUACIÓN CLÍNICA 1:

Bastian, niño de 1 año, consulta por guardia por presentar 72 hs de rinorrea, agitación y dificultad para la alimentación. Consulta previa-

mente en la unidad sanitaria de su barrio donde indican tratamiento con salbutamol en aerosol.

Por persistir con dicho cuadro consulta nuevamente donde se decide su internación.

Antecedentes personales: RNT, PAEG. Embarazo controlado. Serologías no reactivas por libreta. Broncoespasmos a repetición desde los 2 meses de vida. Evaluado por genetista a los 3 meses de edad por sospecha de síndrome genético. Antecedentes familiares de hermano mayor con convulsiones febriles y primo con síndrome de Down. Vacunas incompletas para la edad por libreta, con escasos controles pediátricos.

Examen Físico: Paciente en regular estado general, hemodinámicamente compensado, afebril, normohidratado. FC: 150 lpm. R1 y R2 en 4 focos, soplo holosistólico III/VI, pulsos positivos y simétricos. FR: 52 rpm, regular entrada de aire bilateral, se auscultan subcrepitantes y sibilancias diseminados. Tiraje subcostal. Tórax pectum carinatum superior y excavatum inferior con aumento del espacio intermamilar. Presenta facie con hipertelorismo ocular y baja implantación de pabellón auricular. En piel se destaca la presencia de maculas circulares de color café con leche. Criptorquidia derecha.

Manchas café con leche en abdomen, flanco izquierdo, hombro derecho y región lumbar.

Se solicita radiografía de tórax (frente) donde se observan signos de atrapamiento aéreo e índice cardior torácico aumentado.

Se realiza ecocardiograma donde se observa una comunicación interauricular y estenosis transitorias de rama pulmonar izquierda.

Rx tórax frente que evidencia cardiomegalia y aumento de la trama vascular a predominio derecho.

Permanece internado en nuestro servicio durante 5 días con requerimiento de oxígeno y tratamiento con Salbutamol y Betametasona.

Se decide ampliar estudios para síndrome genético. Se envía muestra para cariotipo.

Impresión diagnóstica: Cardiopatía asociada a síndrome genético con intercurrentia respiratoria.

SITUACIÓN CLÍNICA 2:

Bebé de 2 meses que consulta en nuestro servicio por presentar cuadro de 3 días de evolución de registros febriles de hasta 39.6°C, rechazo parcial del alimento, succión débil e irritabilidad moderada. Asociado en las últimas horas a deposiciones desligadas y vómitos.

Antecedentes personales: RNT/PAEG. Embarazo controlado, serologías no reactivas. Sin antecedentes perinatólogicos ni personales de importancia. Presenta hermano con antecedente de Púrpura de Schonlein Henoch. Vacunas incompletas. Vivienda inadecuada.

Examen físico: Paciente agudamente enferma, clínica y hemodinámicamente compensada, febril (39,4°C), R1 y R2 en 4 focos, silencios libres, eupneica, con buena entrada de aire bilateral sin



ruidos agregados. Presenta edemas en manos, sin godet, eritema bilateral de palmas y plantas que impresiona doloroso al tacto. Irritable, que calma en brazos de su madre.

Se decide internación con diagnóstico de lactante febril sin foco. Se inicia tratamiento con Ceftriaxona a 100mg/kg/día.

Estudios complementarios:

Hemograma: Dentro de parámetros normales.

Eritrosedimentación: Acelerada (63mm).

Sedimento urinario: Células, leucocitos y piocitos escasa cantidad.

Urocultivo-HMCx2: Negativo definitivo.

Punción lumbar: Pleocitosis (16 células). Bacteriológico: Negativo. Viroológico para búsqueda de enterovirus, herpes y parvovirus: Negativo

Viroológico de materia fecal: adenovirus y rotavirus negativos.

La paciente continúa presentando registros febriles durante la internación, luego se agrega un exantema de características polimorfas con lesiones confluentes en tronco, miembros inferiores y superiores que desaparecen a la vitropresión, junto con lesiones erosivas a nivel de mucosa yugal y los pulpejos de los dedos descamados.

Se sospecha de Enfermedad de Kawasaki. Se solicita nuevo laboratorio en el que se observa leucocitosis. Se realiza Ecocardiograma, en el cual se observa dilatación segmentaria de arterias coronarias y derrame pericárdico.

La paciente se deriva a un centro de mayor complejidad donde finalmente fallece a los pocos días por complicaciones.

Comentarios: Con respecto a los casos anteriores podemos concluir que se trata de un paciente con síndrome de Noonan y otro con Enfermedad de Kawasaki. Decidimos utilizar estos ejemplos ya que se caracteriza la primera por presentar un fenotipo característico y fácilmente reconocible y el segundo caso por ser una vasculitis sistémica.

¿Qué entidades clínicas/malformativas pueden presentarse con cardiopatía?

¿Qué cardiopatías predominan en cada una?

Enfermedades genéticas / polimalformativas:

Síndrome de Noonan: Enfermedad monogénica de herencia autosómica dominante y expresividad variable. 1/1000-2500.

Descripción clínica:

Facie: desviación ocular antimongoloide, ptosis, epicanthus, baja implantación de orejas y helix grueso, hipertelorismo.

Genital: pene pequeño, criptorquidia, retraso

maduración puberal.

Osteoarticular: cuello corto y ancho, pectum carinatum superior y excavatum inferior con aumento del espacio intermamilar, talla baja.

Piel: nevus pigmentados, manchas café con leche, lentigos, queratosis rubrapilaris en brazos.

Cardiovascular: Estenosis valvular pulmonar con displasia valvular, Miocardiopatía hipertrófica, CIA y CIV.

Síndrome de Turner: Anomalía cromosómica caracterizada por la falta completa o parcial de un cromosoma X.

Descripción clínica:

Facie: triangular, boca pequeña, implantación baja del cabello, telangiectasias.

Osteoarticular: cuello alado y corto, tórax ancho, mamilas hipoplásicas, cubito valgo.

Genital: pubertad ausente o mínima por disgenesia ovárica.

Uñas hipoplásicas, malformaciones renales.

Cardiovascular: Coartación aorta

Síndrome de Costello: Herencia autosómica dominante. Se caracteriza por una mutación en el gen HRAS en el cromosoma 11. Se cree que existen alrededor de 500 casos en el mundo. Descripción clínica:

Facie: macrocefalia, implantación baja de las orejas, con lóbulos grandes y gruesos, labios inusualmente gruesos.

Osteoarticular: hiperplasia articular, pliegue nuchal, piel laxa con pliegues anormalmente profundos en palmas, plantas y dedos, coloración oscura de la piel, hiperqueratosis palmoplantar, papilomas periorales y perinasales, desviación cubital de la muñeca y del quinto dedo de la mano son muy características, así como la retracción del talón de Aquiles (casi constante), la cifoscoliosis y la osteopenia.

Retraso mental de grado moderado

Cardiovascular: Miocardiopatía hipertrófica

Síndrome de Down: Trisomía del par 21. Cromosomopatía más frecuente y conocida. 1/800. Aumenta con edad materna.

Descripción clínica:

Facie: leve microcefalia, cuello corto, pliegue nuchal ojos almendrados, epicanthus, nariz pequeña, boca pequeña, labios gruesos, macroglosia, paladar ojival, pabellones auriculares pequeños, cutis marmorata.

Osteoarticular: Hipotonía, manos toscas, braquidactilia, pliegue simiano. Retraso mental.
Cardiovascular: Canal AV, CIA, CIV-

Síndrome de Marfan: Es una mutación genética (FBN1) en el cromosoma 15, que produce un tejido conectivo defectuoso por afectación de una proteína llamada fibrilina. Esta proteína se encuentra en el tejido conectivo del esqueleto, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, la piel, los pulmones. 1/5000.

Descripción clínica:

Facies: alargada, subluxación del cristalino.

Osteoarticular: tórax escavado, sifosis, escoliosis, hiperlaxitud, pie plano, hipotonía e hipoplasia muscular, talla alta, piernas largas y escaso panículo adiposo.

Cardiovascular: Aneurisma de aorta en su sa-

lida y parte ascendente. Dilatación de la misma con o sin disección, prolapso e insuficiencia de válvula mitral.

Neurofibromatosis tipo 1: Herencia autosómica dominante. Mutación del gen NF1. Descripción clínica:

Cutáneo: Manchas café con leche (mascador de enfermedad, la totalidad de los pacientes las presentan desde el nacimiento o antes de los tres años), deben presentarse más de 6 manchas mayores a 5mm. Neurofibromas cutáneo. Amartoma pigmentado del iris (Nódulos de Lisch).

Neurológicas: Neurofibromas de los pares craneales, sordera, síndrome cerebeloso, glioma del nervio óptico. Hidrocefalia obstructiva.

Osteoarticular: deformidades vertebrales y escoliosis.

	CIANOSIS	SÍNDROMES	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO
CIA	No	NOONAN, DOWN	Infecciones pulmonares a repetición R2 desdoblado permanente y fijo. Dilatación AD, VD y A. Pulmonar Soplo: sistólico eyectivo en foco pulmonar y dorso Dresler +	Rx: AI normal, aumento vascularización pulmonar. ECC: Hipertrofia y sobrecarga de VD.	Qx entre los 2 y 5 años -Precoz de las infecciones respiratorias.
CIV	No	DOWN	Insuficiencia cardíaca Dilatación de ambos ventrículos y AI Soplo: sistólico de requirgitación que irradia en todas direcciones	Rx: AI agrandada, aumento vascularización pulmonar. Hipertrofia de ambos ventrículos	Qx antes de los 6 meses. -Tratamiento de insuficiencia cardíaca -Prevención de Endocarditis
ESTENOSIS PULMONAR	No	NEUROFIBROMATOSIS	Prácticamente asintomática. Soplo: sistólico eyectivo	Rx: Saliencia arco medio. ECC: Sobrecarga AD	Valvuloplastia con catéter en estenosis moderada a severa. -Prevención de Endocarditis
ESTENOSIS AORTICA	No	NEUROFIBROMATOSIS	Síncope, ángor y palpitaciones Soplo: sistólico eyectivo en foco aórtico que irradia a cuello y frémito supra esternal.	Rx: Dilatación aorta ascendente. Arco inferior convexo con crecimiento del VI	-Insuficiencia cardíaca si hubiera. -Valvuloplastia en casos severos.

COARTACIÓN DE AORTA	No	TURNER	Más frecuente en hombres. Cefalea, claudicación intermitente, frialdad de miembros inferiores Pulsos: Femorales ausentes o disminuidos. TA: mayor en brazos que en piernas. Soplo: sistólico de mayor intensidad en región interescapulovertebral	Rx: Aorta ascendente dilatada con botón deformado Erosión del borde inferior de las costillas en mayores de 5 años (signo de Roesler) ECG: Normal o bloqueo incompleto de rama derecha asociado a hipertrofia VI	Qx a los 2 años. -En RN con insuficiencia cardíaca se realiza angioplastia con catéter o qx. -Prevención de endocarditis.
CANAL AV	Variable	DOWN	Anomalías asociadas: CIA, CIV, alteraciones de válvula mitral y tricúspide con insuficiencia de las mismas. Insuficiencia cardíaca severa, HTA.		Qx temprano -Tratamiento insuficiencia cardíaca. -Prevención de Endocarditis
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA	No	COSTELLO	Insuficiencia cardíaca congestiva o en niños mayores dolor precordial, disnea de esfuerzo, palpitaciones, arritmias y síncope. Soplo: sistólico eyectivo en borde esternal izq. y área mitral que irradia a base del corazón	Rx: Cardiomegalia a expensas de VI ECG: Signos de hipertrofia de VI con alteraciones de la repolarización. Onda T y segmento ST	Betabloqueantes y bloqueantes cálcicos.

Cardiovascular: HTA, estenosis pulmonar o aórtica.

Enfermedades sistémicas:

Enfermedad de Kawasaki: Vasculitis sistémica aguda autolimitada de etiología desconocida que afecta predominantemente a arterias de pequeño y mediano calibre. Es la principal vasculitis en pediatría luego de la Púrpura de Schonlein Henoch. Constituye la causa más común de enfermedad coronaria adquirida en pediatría. El diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha y conocimiento de las manifestaciones frecuentes y poco frecuentes de la enfermedad.

Descripción clínica: Fiebre (entre 39 y 40°) de más de 5 días, edema y eritema en las extremidades, exantema polimórfico en tronco, abdomen y extremidades que se acentúa en región perineal. Inyección conjuntival, fisuras y descamación en cavidad bucal, lengua aframbuesada

con papilas prominentes y eritematosas. Linfadenopatías cervicales. Compromiso articular. Uretritis con piuria estéril, se muestran más irritables a comparación de otras patologías febriles. Meningitis aséptica. Diarrea, vómitos y dolor abdominal. Cardiovasculares: Aneurisma de arterias coronarias. Miocarditis.

Es sumamente importante detectar esta entidad de manera precoz e iniciar terapia inmunosupresora con gammaglobulina para evitar la formación de aneurismas.

Enfermedades reumáticas sistémicas: Son trastornos inflamatorios autoinmunitarios que afectan a múltiples órganos y con frecuencia producen alteraciones en los vasos sanguíneos y el corazón. La cardiopatía puede producirse en pacientes con un diagnóstico ya establecido de un trastorno reumático o ser la forma de presentación inicial en los pacientes sin un diagnóstico previo. La afección cardíaca en estas

ENTIDADES	ANOMALÍAS CARDÍACAS	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO
LUPUS ERYTEMATOSO SISTÉMICO	PERICARDITIS MIOCARDITIS	CRITERIOS LES Dolor torácico Complicación: taponamiento cardíaco Arritmias Deterioro de la función sistólica y anomalías del movimiento de la pared	ECG: microvoltaje Ecocardiografía	Pericardiocentesis: exudado con predominio de neutrófilos, proteínas elevadas y glucosa normal o baja
ARTRITIS REUMATOIDE	PERICARDITIS, VALVULITIS, MIOCARDITIS ENFERMEDAD CORONARIA ATEROSCLERÓTICA	poliartritis simétrica que afecta a las articulaciones pequeñas y grandes	ECG-Ecocardiograma Factor reumatoide (FR), antipéptido citrulinado cíclico (anti-CCP) positivos	metotrexato, sulfasalazina, hidroxicloroquina, inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) AINES
ENFERMEDAD KAWASAKI	VASCULITIS PANCARDITIS TROMBOSIS CORONARIAS ANEURISMAS	Fiebre, infección conjuntiva, nódulos linfáticos, Edema, rash en tronco y eritema palmar Lengua aframbuesada, grietas cavidad bucal	Ecocardiograma	AAS GAMMAGLOBULINA

enfermedades puede variar entre asintomática/leve o grave. Pueden causar anomalías miocárdicas, valvulares, pericárdicas y del sistema de conducción, como así también se han asociado a aterosclerosis prematura, que da lugar a cardiopatía isquémica a una edad temprana y constituyen una causa importante de morbilidad.

Se analizan aquí las manifestaciones cardíacas de las enfermedades reumáticas específicas que se asocian con mayor frecuencia a cardiopatías

Comentario del Especialista

La cardiopatía congénita tiene una incidencia importante, ya que representa el 30% de los recién nacidos.

En este capítulo de pediatría en red, se presentan dos casos clínicos que espero resulte práctico para nuestra práctica diaria.

Los casos elegidos han sido alteraciones cromosómicas y cutáneas, las más relevantes a nuestro parecer, para que al pediatra general le genere la duda de si es posible la presencia de cardiopatía congénita cómo adquirida.

El primer caso es un síndrome de noonan típico. Se mencionan otros síndromes genéticos

como, Turner, Down con sus Cardiopatías asociadas y síndromes cutáneos como la neurofibromatosis.

El segundo caso de enfermedad de Kawasaki, es muy importante sospecharla ya que instaurándose un tratamiento temprano se pueden evitar las alteraciones coronarias.

Bibliografía

- Cruz Hernández, Juan Bosch Hugas, Manual ilustrado de enfermedades raras, Editorial Ergon 2014.
- Aracena A. Mariana. Cardiopatías congénitas y síndromes malformativos-genéticos. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2003 Jul; 74(4): 426-431.
- Guía, J. M; Guillén, E; Castro, F. J; Ibáñez, J; Gracián, M; Bosch, V. Síndromes polimalformativos y cardiopatías congénitas. Estudio en la comunidad autónoma de Murcia en 1.216 niños (1978-1990). Rev. esp. pediatr. (Ed. impr.); 56(4): 314-320, jul. 2000.
- Kliegman, Behrman y co, Nelson Tratado de pediatría 18 Edición, Elsevier. Capítulo 424 al 445. Cardiopatías congénitas
- Voyer, Luis E. Ruvinsky, Raúl, Cambiano, Carlos, Libro Pediatría, 3 edición. Ediciones Journal, capítulo Cardiopatías congénitas.

*Dr. Cristian Sánchez Vocci

Cardiólogo Infantil

INSUFICIENCIA CARDÍACA

Hospital Mercante de José C. Paz



Dra. C. Yevara

Dra. S. Ruiz Barja

Residentes

Dr. Maximiliano Schianni

Instructor de residentes

Dra. M. Quayat*

Sumario

Un análisis actualizado de la insuficiencia cardíaca en Pediatría.

Insuficiencia cardíaca es el estado fisiológico en el cual el corazón es incapaz de mantener un volumen minuto adecuado a las demandas metabólicas y hemodinámicas normales.

Clasificación

Con alteración de la función sistólica: En general hay 2 causas de IC Sistólica

Sobrecarga de presión (aumento de poscarga) por ejemplo:

Cardiopatías obstructivas (Estenosis Aortica, Estenosis Pulmonar, Coartación de Aorta, etc.) que presentan un VCM disminuido.

Por alteración miocárdica (carga normal con contractilidad alterada)

Secundaria a Canalopatías congénitas o adquiridas (Miocarditis, Miocardiopatías o Enfermedades Isquémicas) que presentan también VCM disminuido.

Estos pacientes con IC Sistólica y Volumen minuto disminuido (Síndrome de bajo gasto Cardíaco) evidencian el deterioro de la función ventricular, presión de fin de diástole elevada y

aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno.

Insuficiencia Cardíaca Diastólica

El 75% de las cardiopatías congénitas tienen función sistólica conservada. Entonces ¿por qué los pacientes con IC sistólica conservada están en IC?

Por la disfunción diastólica

Desde el punto de vista fisiológico, la diástole ventricular se divide en dos fases:

Fase Precoz = Relajación ventricular

Es un funcionamiento activo y comprende:

- ✓ Periodo de relajación isovolumétrica
- ✓ Llenado ventricular rápido

Fase o Diástole Tardía: es un fenómeno pasivo = comprende llenado ventricular lento y la sístole auricular y depende de las complacencias ventriculares.

La disfunción diastólica ocurrirá en caso de aumento del espesor de la pared ventricular y retraso de la relajación ventricular.

La importancia de reconocer la IC diastólica se relaciona con la terapéutica, ya que los cardiotónicos (digitales) excepto por la disminución de la

taquicardia no son eficientemente efectivos. En cambio la disminución de la precarga con régimen hipo sódico, diuréticos y o vasodilatadores es la terapéutica efectiva según la fisiopatología.

Otra clasificación es:

Insuficiencia Cardíaca Derecha: Con falla del ventrículo derecho por mantener un volumen minuto adecuado y reciben la sangre y reciben la sangre sistémica venosa.

Insuficiencia cardíaca Izquierda: Falla de ventrículo izquierdo para mantener una perfusión sistémica adecuada y drenan satisfactoriamente la circulación pulmonar.

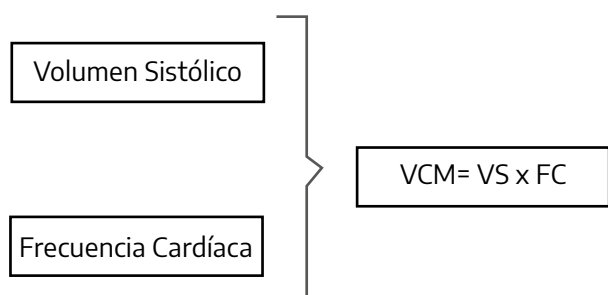
Insuficiencia Cardíaca Congestiva o bi-ventriculares: Falla de ambos ventrículos para mantener su función.

A su vez pueden ser:

- ✓ Agudas
- ✓ Crónicos
- ✓ Compensado: Mecanismos adaptativos logran un volumen minuto adecuado.
- ✓ Descompensado: Dichos mecanismos no logran un volumen minuto adecuado.
- ✓ Crónico refractario: Cuando la función cardíaca persiste anormal por largo tiempo sin respuesta a la terapéutica y no llegan a compensar.

Fisiopatología

El volumen minuto o Gasto Cardíaco dependen de:



Los principales determinantes que regulan el volumen sistólico y que permiten un Volumen minuto adecuado son:

- ✓ Contractilidad
- ✓ Precarga
- ✓ Poscarga
- ✓ Distensibilidad
- ✓ Frecuencia cardíaca

Contractilidad: Fuerza de contracción intrínseca del miocardio independiente de la carga.

Es regulado por el Sistema Nervioso Autónomo, catecolaminas circulantes y, además, el nivel de activación del músculo cardíaco está determinado por la cantidad de calcio iónico unido a las proteínas.

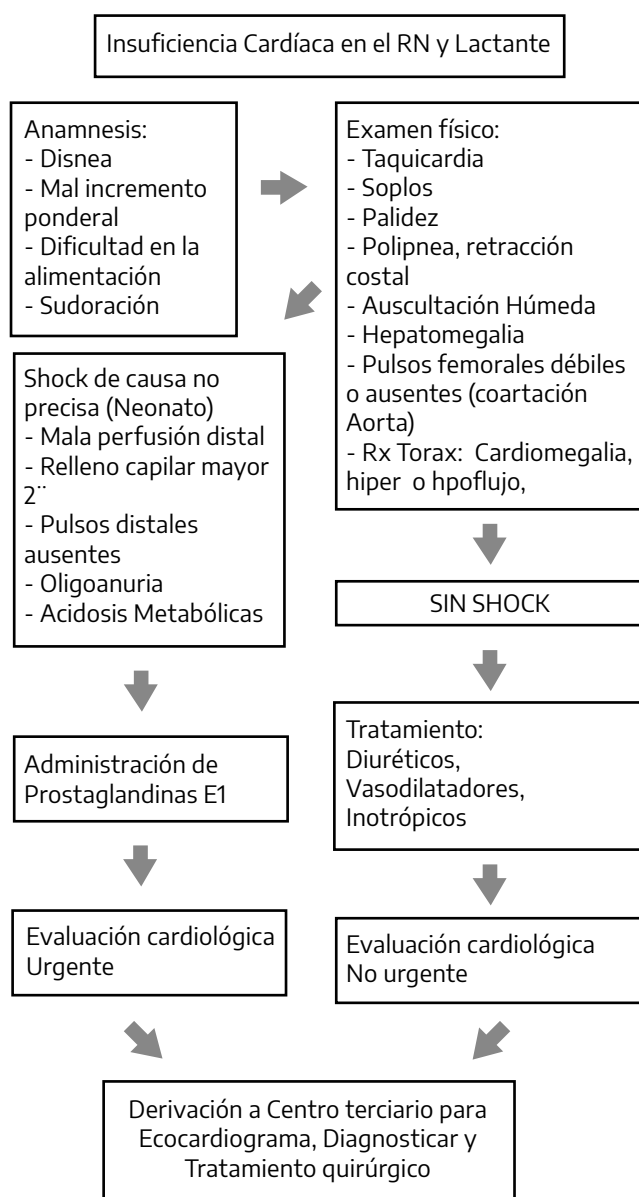
Precarga: Volumen de llenado diastólico

De acuerdo a la Ley de Frank Starling

El aumento PFDV (precarga) determina un mejor trabajo cardíaco hasta un límite por encima del cual dicho trabajo disminuye.

La precarga a su vez está determinada por múltiples factores:

- Volemia
- Presión intratorácica
- Presión intrapericárdica
- Tono venoso



Poscarga: Es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Valorada con sustancias sistémicas y las presiones arteriales.

Frecuencia Cardíaca: La frecuencia de la contracción afecta el rendimiento cardíaco por influencias la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y además por modificar el tiempo de llenado diastólico.

En el niño y adolescente la sintomatología nos permite determinar el grado de incapacidad.

Grado I: Corre y juega pero se cansa más que otros chicos de su edad.

Grado II: Camina varias cuerdas (200 – 500 metros) pero se fatiga ostensiblemente.

Grado III: camina 1 cuerda o más (100 – 200 metros) pero a paso lento.

Grado IV: No camina, solo en la habitación

Tratamiento sintomático de la IC:

Tratamiento General:

- Relativo: En incapacidad Grado I y II
- Absoluto: En incapacidad Grado III y IV
- Posición semisentada= para disminuir el retorno venoso sistémico y descender el diafragma, facilitando la respiración.
- Control de temperatura corporal.
- Administración de oxígeno humidificado y calentado.
- Manejo de agua e iones.
- I.C. Compensada: régimen hipo sódico y aporte de líquidos según mantenimiento.
- I.C. descompensado: Hidratación parenteral (80ml/kg/día) o (1500 ml/m²/SC)

- Tratamiento de infección y anemia si se hallan asociados.

Tratamiento específico:

- Modificar Precarga:
- Aumentándola: En I.C. con bajo volumen o hipovolemia disminuida.
- Infusión de volumen para incrementar el retorno venoso.
- Disminuyéndola: Diuréticos y Vasodiladores.
- Disminuir Poscarga: Disminuir las resistencias sistémicas (vasodilatadores arteriales o mixtos).
- Aumento de los inotropismo:
- Mejorando el estado metabólico: pH, por, glucemia, calcio, K, hemoglobina.
- Con drogas inotrópicas + digitales.
- Control de frecuencia cardíaca: Si hay arritmias.

Bibliografía

-

Díaz Góngora G. Cardiología Pediátrica Colombia 2003.

Kreutzer E. Cardiología Pediátrica 1993

Magliola R Moreno G. Avances en Cardiología Congénita 2006.

Magliola R Moreno. Actualización de Insuficiencia Cardíaca

***Dra. M. Quayat**

Cardióloga infantil Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
CABA

MIOCARDIOPATÍAS

Hospital Mercante de José C. Paz



Dra. M. Almirón

Dra. R. Sánchez

Dra. J. Kuschnir

Residentes

Dr. M. Schianni

Instructor de residentes

Dra. M. Quayat*

Revisora

Sumario

Las miocardiopatías (MCP) comprenden a un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo cardíaco, asociadas a disfunción cardíaca, las que presentan alta morbi-mortalidad en lactantes y niños. Se clasifican de acuerdo a la fisiopatología dominante. Se ofrece una actualización del tema.

Clasificación de Miocardiopatías:

- ✓ Dilatada
- ✓ Hipertrófica
- ✓ Restrictiva
- ✓ Displasia Arritmogénica VD

MIOCARDIOPATÍA DILATADA

Es la forma más común de MCP, caracterizándose por un deterioro en la contractilidad, que se acompaña de dilatación del ventrículo izquierdo, derecho o de ambos. La forma familiar ocurre en el 20 – 30% de los casos, teniendo la mayoría transmisión autosómica dominante.

Existen posibilidades de que este tipo de MCP sea secundario a un proceso tipo miocarditis de

tipo viral (principalmente los virus Cocksackie e Influenza A y B) o a través de procesos inmunológicos sobre una predisposición genética.

Idiopática. 50%

Infarto de Miocardio.

Metabólicas. Descenso de Calcio. Déficit de Selenio. Anemias.

Endocrinológicas: Feocromocitoma, Hipo e hipertiroidismo.

ALCAPA: implantación anómala de A. Coronarias.

Colangenopatías.

Tóxicos: Antracíclicos, antirretrovirales, urémicos, cocaína y HIV.

Duchenne Arritmia Sobrecarga de volumen.

Alteraciones genéticas: en gen que codifica distrofia y fibras musculares HLAIII (DR4 – dq Lu4).

Fisiopatología

Encontramos la dilatación ventricular con disfunción contráctil, tipo FALLA SISTÓLICA. La CP. dilatada estimula el SRAA , aumenta actividad simpática lo que favorece la hipertrofia, apoptosis, remodelamiento del miocardio y arritmias.

Cuadro Clínico

IC taquicardia, taquipnea, insaturación ligera EAP, bajo débito. En general los ruidos cardíacos son hipo fonéticos y no suelen auscultarse soplos (salvo que exista Insuficiencia Mitral), siendo casi patognomónico de esta enfermedad la presencia de un “corazón grande y silencioso”. Los pulsos casi siempre son débiles y filiformes, acompañándose de hipotensión y taquicardia.

ECG: taquicardia sinusal, trastorno difuso de la repolarización, complejos de bajos voltajes y/o cambios del ST-T si se trata de una miocarditis, aunque son signos de baja sensibilidad y especificidad.

RxTx: Cardiomegalia severa HTVCP (hipertensión venocapilar pulmonar)
Derrame pleural, derrame pericárdico

Solicito

- 1) Ecocardiograma doppler
- 2) SPECT (visualizando el área afectada por la coronaria comprometida)
- 3) cateterismo, biopsia

Lab: medio interno, serologías virales, HIV, collagenograma, MTB, carnitina, hormona tiroides. El valor de ácido úrico, es un marcador asociado a daño endotelial y el aumento mayor de 500 miliosmol /L se asocia a mal pronóstico.

Ecocardiograma doppler coronario: aumento de las 4 cavidades, disquinesia segmentaria, insuficiencia mitral/VCI y supra hepáticas dilatadas. Derrame pericárdico.

TTO: el de la insuficiencia cardíaca: furosemida, espironolactona, Enalapril (remodela), Beta bloqueantes, Carvedilol

Reposo en cuadro agudo

Restricción hidrosalina

Vacuna antigripal, antineumococo

Anticoagulación:

- FE menor de 20%(fracción eyección)

- FA menor de 15%(fracción acortamiento)

Trasplante: cuando el primer tratamiento no tiene respuesta, y el paciente continúa descompensado.

Levosimendan: Es vasodilatador coronario y sistémico, aumenta la sensibilidad al Ca. Estabilizando cambios conformacionales inducidos por Ca en la troponina C. No aumenta la demanda de oxígeno. Efectos adversos: cefalea,

hipotensión y nauseas.

Carnitina: facilita el transporte de ácidos grasos a la mitocondria, aunque no sea la causa de la miocardiopatía mitocondrial. Se utiliza en fase terminal o descompensada. Dosis: de 1 a 3g /día.

Importante: tener estudio metabólico previo porque si la afectación es en la beta oxidación de ácidos grasos de cadena corta, el efecto es perjudicial.

Pronóstico: a los 5 años presenta una mortalidad de hasta el 80%

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

Es la hipertrofia del miocardio sin dilatación, con DISFUNCIÓN DIASTÓLICA en ausencia de causa cardíaca o sistémica, puede ser:

asimétrica:95% (septum y ápex)

simétrica: 5% enfermedad de Pompe

El 25% obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo

Etiología

Es importante señalar que es una patología de tipo familiar en el 60% de los casos, con una transmisión autosómica dominante, los casos restantes se consideran como de tipo no familiar, mutaciones como la del gen de la troponina cardíaca T.

Además hay una predominancia en el sexo masculino 2:1. Debe señalarse además, la asociación relativamente frecuente con el Sme de Noonan, y con la Ataxia de Friedrich.

Fisiopatología

Desde este punto de vista, las características básicas de la miocardiopatía hipertrófica son:

1.- Dificultad al llenado ventricular por la rigidez cardíaca, que existe por la hipertrofia, lo cual implica compromiso en la FUNCIÓN DIASTÓLICA.

2.- La obstrucción a la salida de VI, que puede ser secundaria a la hipertrofia septal asimétrica, o al movimiento anterior sistólico de la valva anterior mitral; la obstrucción puede ocurrir en reposo o durante estímulos, pero no se encuentra en todos los pacientes.

3.- Aumento del vaciado ventricular, por aumento de la fuerza de contracción ventricular.

4.- Debido a la misma hipertrofia puede existir hipoxia miocárdica, secundaria al compromiso del flujo coronario, por compresión de las pequeñas arteriolas, lo que origina arritmias cardíacas

Teniendo en cuenta dichas características, se comprende que cuanto mayor sea la hipertrofia, la compliance ventricular estará más comprometida, por lo tanto con dificultad en el llenado ventricular, sumado a taquicardia, puede comprometerse la presión en aurícula izquierda, con la presencia de edema aguda de pulmón; además esto podría explicar los Síncopes en estos pacientes.

Cuadro clínico

Aumento el latido apical, desdoblamiento de 2R, paradójico. SS eyec.regurgitativo en IM

Puede presentarse con síncope y muerte súbita

Electrocardiograma: anormal, con cambios inespecíficos; los hallazgos más frecuentes son: cambios en la onda T y el segmento ST, arritmias cardíacas (principalmente extrasístoles ventriculares), ondas Q anormales e hipertrofia de VI, y en los lactantes con compromiso biventricular puede encontrarse crecimiento predominante del V.D.

Rx de tórax:

Simula silueta cardíaca normal (sin características particulares) y puede haber signos de congestión venocapilar pulmonar.

Ecocardiografía: VI hipertrófico con obstrucción del TSVI.

TTo:

Evitar inotrópicos.

Betabloqueantes: disminuyen el consumo de oxígeno.

Bloqueadores de Ca.

Marcapasos: en miocardiopatía septal asimétrica.

Cirugía:

Miotomía septal transaortica a los 5 años.Trasplante.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

De los tres tipos de cardiomiopatías, éste es el menos frecuente en niños y, su denominación implica un aspecto básicamente funcional con compromiso de FUNCIÓN DIASTÓLICA con función sistólica conservada.

Los pacientes se caracterizan por tener una disminución de la compliance ventricular con aumento de la presión de llenado, que dificulta el vaciado auricular, con una función sistólica normal, como ya habíamos dicho. Lo cual es secundario a un proceso infiltrativo que compro-

mete al subendocardio o al miocardio, de uno o ambos ventrículos. Dependiendo del ventrículo afectado o si son ambos, habrá un determinado cuadro clínico. Cuando la causa de la MCP Restrictiva es un proceso infiltrativo, es frecuente encontrar trastornos de la conducción, arritmias ventriculares y puede haber muerte súbita.

Etiología

Idiopática, familiar, Sme Loeffler, Amiloidosis, Enf. De Depósito (gaucher-Hurler- Fabry), Sarcoidosis, Hemocromatosis, Endomiocardiofibrosis.

Cuadro Clínico

La clínica de estos pacientes es generalmente de insuficiencia cardíaca, que variará si el compromiso es izquierdo, derecho o biventricular. En el primer caso el paciente comienza con disnea que progresa rápidamente a insuficiencia cardíaca congestiva con edemas y hepatomegalia; por el contrario cuando el compromiso es del VD., el cuadro predominante es el de una gran hepatomegalia y edemas. En todos los casos hay hiperactividad cardíaca. En la auscultación, puede encontrarse soplo de regurgitación, que será mitral o tricuspídea, según la válvula afectada.

Electrocardiograma: muestra trastornos del ST y onda T, puede haber bajos voltajes si hay derrame pericárdico acompañando al cuadro, pero lo predominante es la presencia de signos de crecimiento del ventrículo y aurículas comprometidos.

Rx de tórax: se evidencia leve cardiomegalia, derrame pleural, aumento AD, aumento AI, hipertensión venocapilar pulmonar.

Ecocardiograma: Ayuda mucho ya que permite precisar el tipo de miocardiopatía, permitiendo valorar la disfunción existente y si es que hay disfunción valvular concomitante.

Tratamiento

Hay que ser muy cauteloso con los diuréticos, ya que disminuyen la precarga y, con los vasodilatadores. Por el resto se usarán B-Bloqueantes, bloqueantes Cálculo y digitálicos.

Anti coagulación siempre.

Pronóstico

Es muy malo, con mortalidad alta a corto plazo.

DISPLASIA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO

Es un trastorno caracterizado por una infiltración fibroadiposa del ventrículo derecho, y que puede comprometer al VI en solo 30 % de los casos, lo cual es de muy mal pronóstico. Si bien hay formas esporádicas, las familiares se dan en el 50 % de los casos, haciendo obligatoria la evaluación de los parientes.

La forma de transmisión es autosómica dominante, con penetrancia variable.

La presentación clínica, suele ser con episodios de arritmia ventricular con imagen de bloqueo de rama izquierda (dependiendo del sitio de infiltración), síncope, manifestaciones de ICC, y muerte súbita, que en algunos casos suele ser el debut de la enfermedad.

El diagnóstico se realiza por suma de criterios que reúnen, el ECG, ecocardiograma y muchas veces la Resonancia Magnética Nuclear.

La biopsia no es un elemento confiable, debido a falsos positivos o negativos, si la zona evaluada no es representativa.

ECG: puede presentar ritmo sinusal, alteración en conducción de rama derecha, ondas Tnegativas de V1 a V3.

El tto depende de la severidad y manifestaciones clínicas de la enfermedad, pudiendo ser farmacológico, en casos seleccionados implante de cardiodesfibrilador automático o trasplante cardíaco.

Bibliografía

-

Díaz, Márquez, Núñez, Sandoval. *Cardiomiopatías en edad pediátrica.*

En: *Cardiología Pediátrica.* Gabriel F. Góngora.

Piñeiro, Bustamante Labarta, Guevara, Migliore, Roisinblit. *Eco cardiografía para la toma de decisiones.*

Somoza FJ, Marino B. *Cardiopatías congénitas.*

*Dra. M. Quayat Revisora

Cardióloga infantil, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
CABA

PERICARDITIS

Hospital Mercante de José C. Paz



Dra. J. Kuschnir

Residente

Dr. M. Schianni

Instructor de Residentes

Dra. M. Quayat*

Revisora

Sumario

La pericarditis aguda es un síndrome clínico debido a la reacción inflamatoria del pericardio en respuesta a diferentes agresiones de naturaleza muy diversa. La inflamación pericárdica puede dar como resultado la producción de líquido en el saco pericárdico, en cuyo caso hablamos de derrame pericárdico, con la eventual posibilidad de taponamiento cardíaco; se pueden producir también adherencias entre ambas capas del pericardio o reacción fibrosa retráctil del mismo, que conduce a la pericarditis constrictiva.

La etiología puede variar notablemente de un área geográfica a otra. En nuestro medio, las causas más frecuentes son las infecciosas, las secundarias a pericardiotomía quirúrgica y las neoplasias en el medio hospitalario.

ETIOLOGÍA

- Idiopática.
- Infecciosa:
- Viral: Coxsackievirus, echovirus tipo 6, adenovirus, Influenzae, herpes zóster, Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Bacteriana (pericarditis purulenta): Staphylococcus aureus, Haemophilus in-

fluenzae, neumococo, Neisseria meningitidis, estreptococos.

- Tuberculosis.
- Fúngica: Aspergillus, Histoplasma. / Toxoplasma, Rickettsia.
- Traumática: perforación por catéter venoso central, marcapasos, traumatismo penetrante o cerrado de tórax.
- Síndrome post-pericardiotomía.
- Colagenopatías: artritis reumatoide juvenil (ARJ), lupus eritematoso sistémico (LES), esclerodermia, fiebre reumática, dermatomiositis.
- Fármacos: anticoagulantes, difenilhidantoína, procainamida, penicilina, hidralazina, isoniácida, doxorubicina, daunorrubicina, dantroleno.
- Neoplasias: linfomas, leucosis, rabdomiosarcomas.
- Radiación mediastínica.
- Otras: Kawasaki, talasemia, mixedema, enfermedad inflamatoria intestinal, uremia, diálisis.

FISIOPATOLOGÍA

Una presencia de líquido en el espacio pericárdico superior a la normal (15-50 mL en adultos o 1 mL/kg en niños) acompaña casi constantemente a la pericarditis clínica en la infancia, de

forma que la ausencia de derrame a ciertas edades hace difícil el diagnóstico de pericarditis.

La patogenia de los signos y síntomas del derrame pericárdico está determinada por el aumento de la presión intrapericárdica, pero dicho aumento depende no sólo de la cantidad absoluta de líquido, sino también de la rapidez con que se acumula y de las características del pericardio.

La acumulación rápida se tolera peor que la lenta, que puede permitir un gran acúmulo de líquido sin producir síntomas y sin elevar significativamente la presión intrapericárdica; a veces, la primera manifestación son síntomas secundarios a compresión de estructuras vecinas, como disfagia por compresión del esófago, tos por compresión de un bronquio o de la tráquea, disnea por compresión del parénquima pulmonar, hipo por compresión del nervio frénico o afonía por compresión del nervio laríngeo recurrente.

Con el aumento de la presión intrapericárdica se elevan las presiones de todas las cavidades del corazón y se produce el taponamiento cardíaco, síndrome clínico-hemodinámico resultante de la compresión del corazón, que impide el adecuado llenado diastólico. El taponamiento pericárdico es un síndrome con un continuum en cuanto a gradación de severidad, que puede ir desde ligeros aumentos de la presión intrapericárdica sin repercusión clínica ni hemodinámica reconocible hasta un cuadro grave de bajo gasto cardíaco y muerte.

Los signos del taponamiento aparecen por la disminución del llenado ventricular, que de forma secundaria produce limitación del retorno venoso, con la consiguiente congestión venosa sistémica, y disminución del gasto cardíaco. En compensación, hay taquicardia y aumento de las resistencias periféricas. Al disminuir el gasto cardíaco, los pulsos periféricos y la presión del pulso son pequeños, y la presión sistólica está baja. La presión venosa elevada produce distensión de las venas del cuello y hepatomegalia.

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA

Los síntomas más comunes de la pericarditis son el dolor torácico y la fiebre. El dolor precordial, síntoma dominante en adultos, adquiere menor importancia en la edad pediátrica y puede pasar inadvertido en niños pequeños o manifestarse por discomfort e intranquilidad. Cuando

está presente, su intensidad y localización es muy variable.

Se localiza en región retroesternal y precordial izquierda, y frecuentemente se irradia al cuello, a ambos trapecios o al epigastrio. Suele aumentar al tumbarse el niño, con la tos, la inspiración profunda o la deglución, y mejora al sentarse e inclinarse hacia delante. En ocasiones existe dolor pleurítico asociado por afectación concomitante de la pleura.

La fiebre es variable; puede ser elevada, pero por lo general se trata de febrícula.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Los signos característicos son el roce pericárdico y la disminución de los tonos cardíacos.

El roce pericárdico es patognomónico de pericarditis aguda, aunque su ausencia no la excluye.

A semeja el ruido de frote de dos superficies de cuero o del frote del pelo entre los dedos. Se ausculta mejor con la campana del fonendo y con el paciente sentado e inclinado hacia delante. Es característica su evanescencia y los cambios del mismo entre exploraciones. A medida que aumenta el derrame pericárdico, el roce se vuelve intermitente hasta desaparecer por completo.

Con el aumento del derrame y de la presión intrapericárdica puede desarrollarse taponamiento cardíaco. Los niños suelen presentar intranquilidad y distrés respiratorio. El movimiento precordial está disminuido, y los ruidos cardíacos pueden oírse apagados por la atenuación que produce el líquido.

Los signos característicos de taponamiento son la elevación de la presión venosa yugular, pulso paradójico y descenso de la presión sistólica y de la presión del pulso.

Ingurgitación yugular
Tonos cardíacos débiles
Pulso paradójico > 20 mmHg
Estrechamiento de la presión del pulso
Taquicardia
Hipotensión
Disnea
Enlentecimiento del llenado capilar
Hepatomegalia
Oliguria

Tabla 1. Manifestaciones clínicas de taponamiento pericárdico

Al disminuir el volumen sistólico aparece taquicardia, taquipnea y vasoconstricción periférica; y cuando este mecanismo compensatorio falla, signos de hipoperfusión sistémica y oliguria. En lactantes y niños pequeños, la taquicardia puede ser en ocasiones el único signo presente.

Puede existir hepatomegalia, ascitis y edema periférico en derrames prolongados.

Cuando el taponamiento es severo, el pulso paradójico puede no apreciarse por la marcada hipotensión, pero la presión venosa yugular suele estar claramente elevada.

En caso de taponamiento agudo y grave, puede producirse un cuadro severo de bajo gasto cardíaco, colapso hemodinámico y muerte. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta en los neonatos con catéteres centrales que presentan un brusco deterioro de la función respiratoria o hemodinámica, ya que el taponamiento agudo por perforación del catéter es una complicación ampliamente documentada que requiere un alto índice de sospecha.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Los exámenes complementarios que pueden contribuir al diagnóstico son los siguientes.

Radiografía de tórax

La silueta cardíaca puede ser normal, dilatándose con derrames importantes. La cardiomegalia es proporcional al grado de derrame, pero no refleja el compromiso hemodinámico.

Electrocardiograma

Suele estar alterado, con cambios en la repolarización ventricular. Se definen varias fases en la evolución típica de la pericarditis, aunque en niños es poco frecuente observar los cambios típicos de las cuatro fases. En la inicial hay elevación generalizada del segmento ST con onda T positiva y depresión del intervalo PR. Esta fase puede durar horas o pocos días, y no es constante. Se sigue de aplanamiento del ST y de la onda T. Posteriormente se invierte la onda T de forma difusa, pudiendo durar esta fase hasta semanas o meses, y finalmente se normaliza la onda T.

En caso de derrame importante, puede detectarse bajo voltaje generalizado y, en ocasiones, alternancia eléctrica (variaciones cíclicas de la amplitud de QRS).

Ecocardiograma

La ecocardiografía es la técnica de elección para el diagnóstico, cuantificación y seguimien-

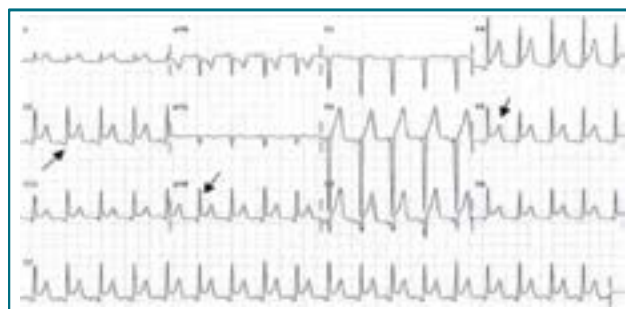


Figura 1. Elevación generalizada del segmento ST y depresión del intervalo PR en la fase inicial de pericarditis.



Figura 2. Derrame pericárdico masivo con colapso diastólico de la pared del ventrículo derecho.

to del derrame. Se exige que la separación de ambas hojas pericárdicas se observe durante todo el ciclo cardíaco. Pequeñas cantidades de líquido tienden a acumularse inicialmente entre la pared del ventrículo izquierdo y el pericardio posterior. Al aumentar la cantidad, puede llegar a envolver por completo al anterior. A veces, los derrames son encapsulados (frecuentes en derrames tras cirugía cardíaca) y circunscritos a determinadas regiones.

Para el diagnóstico de taponamiento cardíaco, los signos ecocardiográficos más sensibles parecen ser el colapso telediastólico de aurícula derecha y el colapso diastólico de ventrículo derecho.

El ecocardiograma puede también ayudar en el diagnóstico de pericarditis constrictiva al revelar en modo M dos líneas paralelas (pericardio visceral y parietal) engrosadas o múltiples ecos hiperdensos. En modo 2D puede observarse un pericardio de aspecto inmóvil y engrosado, desplazamiento brusco del tabique interventricular durante el llenado diastólico precoz y dilatación de las venas hepáticas y la vena cava inferior.

Exámenes de laboratorio

Con excepción de algunas etiologías (uremia, leucemia), la analítica de sangre suele mostrar datos inespecíficos. El hemograma suele mostrar leucocitosis con desviación izquierda y aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG), que tienen utilidad para monitorizar la evolución. Pueden realizarse cultivos de sangre, heces y orina, serología y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para virus y Mantoux. Según evolución y sospecha diagnóstica, puede estudiarse crioaglutininas para descartar infecciones por *Mycoplasma*, serología para virus de Epstein-Barr (VEB), anticuerpos antinucleares (ANA), factor reumatoide y hormonas tiroideas. Puede observarse elevación leve de las troponinas cardíacas en los niños con pericarditis aguda.

Análisis del líquido pericárdico

En los casos en que esté indicada la pericardiocentesis, se investigará: estudio citológico, bioquímico (proteínas, glucosa, colesterol y triglicéridos), cultivos para virus, bacterias, hongos y micobacterias, densidad, lactato deshidrogenasa (LDH), adenosina desaminasa (ADA) y tinción de Ziehl-Neelsen.

Presión venosa central

Existe un aumento de la presión venosa central (PVC). La curva de presión se hace monofásica. El descenso venoso "y" se atenúa y luego desaparece.

Pulsioximetría

Descenso de la saturación de O₂ por vasoconstricción periférica.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

- Todo niño con sospecha de enfermedad pericárdica debe ser remitido al hospital para estudio y tratamiento.
- Son indicaciones de ingreso en UCI pediátrica: sepsis, shock séptico, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo, signos de taponamiento y derrames grandes.
- Manejo del niño con sospecha de pericarditis
- Examen físico completo y anamnesis detallada (antecedentes de infección, fármacos, traumatismos, enfermedad renal o neoplásica).
- Monitorización: frecuencia cardíaca (FC) y saturación de O₂ continuos, frecuencia respiratoria (FR), temperatura, tensión

arterial.

- Se debe realizar ecocardiograma a todo niño con sospecha de enfermedad pericárdica.
- Acceso venoso periférico.
- Exámenes complementarios en el primer escalón (a valorar según orientación diagnóstica):
 - Hemograma, VSG, PCR, creatinfosfocinasa (CPK), LDH, gasometría, función renal y hepática, ionograma y proteinograma. Mantoux. Hemocultivos para bacterias y virus. Serología (micoplasma, TORCH –toxoplasmosis, otras, rubeola, citomegalovirus, herpes, VEB y adenovirus). Radiografía de tórax. Electrocardiograma.

- Cuando la historia clínica sugiera enfermedad de más de una semana de duración, investigar: ANA, anti-ADN, anticuerpos antitejido, seroaglutinaciones, aislamiento del bacilo de Koch en aspirado gástrico.

Tratamiento general

El tratamiento de la pericarditis es principalmente médico y se basa en reposo y antiinflamatorios, además del tratamiento etiológico, si lo hubiera.

Reposo en cama hasta desaparición de la fiebre y del dolor.

Antiinflamatorios:

- AINE: se administran durante un mínimo de 2 semanas y se retiran paulatinamente.

AAS: 60-100 mg/kg/día en 3-4 dosis, durante un mínimo de 2 semanas. Control de salicilemia.

Ibuprofeno: 15-30 mg/kg/día en 3-4 dosis.

Indometacina: 1-3 mg/kg/día (máximo 100 mg/día) en 3-4 dosis.

Colchicina: sola o asociada a antiinflamatorios no esteroideos (AINE). La colchicina parece ser el medicamento estrella en el tratamiento de la pericarditis recidivante o incesante), y está en estudio su papel en el tratamiento inicial de la pericarditis aguda.

La dosis inicial recomendada es de 0,02 mg/kg/día, pudiendo aumentarse cada día hasta alcanzar la dosis deseada (no más de 1 mg/día, por lo general) según tolerancia digestiva. La diarrea es el principal efecto limitante, y suele responder rápidamente a la supresión del fármaco. La duración del tratamiento varía entre 6 y 18 semanas. Algunos recomiendan mantener el tratamiento a dosis bajas (0,5 mg/día) durante un año.

Corticoides: es controvertido su uso porque parece favorecer la recurrencia del derrame, por lo que no son fármacos de primera elección en el tratamiento de la pericarditis aguda. Pueden estar indicados en casos de persistencia de dolor intenso o fiebre alta, rebeldes a tratamiento con AINE, de más de 5 días de evolución: prednisona o metilprednisona, 1-2 mg/kg/día. Generalmente es suficiente con una semana de tratamiento y reducción progresiva según evolución. Si se presenta recurrencia durante la retirada, se debe aumentar la dosis a la mínima que controló el cuadro y retirarlos muy lentamente durante 2 o 3 meses.

Pericardiocentesis:

El rendimiento diagnóstico de la pericardiocentesis es muy bajo, por lo que no está justificada su realización con este fin, salvo que se sospeche pericarditis purulenta. Indicaciones para pericardiocentesis (nivel de recomendación de clase I):

Taponamiento cardíaco clínico (hipotensión, bajo gasto o shock) moderado o severo, en presencia de un derrame pericárdico como mínimo moderado en el ecocardiograma.

Sospecha de pericarditis purulenta.

Drenaje quirúrgico:

Preferible en caso de pericarditis purulenta; su equivalente mayor, la pericardiectomía, está indicado en pericarditis constrictiva con clínica de insuficiencia cardíaca derecha severa (clase I) y en pacientes clínicamente intratables (derrame pericárdico recidivante masivo tras pericardiocentesis de más de 6 meses de evolución) (clase IIA). Es muy efectivo para evitar recaídas.

Tratamiento del taponamiento cardíaco

El objetivo del tratamiento es mejorar el gasto cardíaco y aliviar el taponamiento con pericardiocentesis. Debe evitarse el uso de diuréticos y vasodilatadores. Hay que tener en cuenta que la intubación y ventilación mecánica a presión positiva aumenta la presión intratorácica y disminuye aún más el gasto cardíaco.

En caso necesario, deben evitarse presiones positivas al final de la espiración (PEEP) elevadas. Se suspenderá o cambiará el tratamiento anticoagulante si lo hubiese.

Las medidas inmediatas a tomar, además de las generales descritas, son:

- Canalización de vena periférica.
- Colocar, si es posible, catéter venoso central.

- Puede ser beneficiosa la infusión rápida de líquidos, cristaloides o coloides (20 mL/kg) previa a la pericardiocentesis.
- Inotrópicos: dopamina, dobutamina, adrenalina.
- Oxigenoterapia. Intubación si hay shock o insuficiencia respiratoria severa.

Pericardiocentesis

Existen varias técnicas según la urgencia del caso y disponibilidad de medios. De menor a mayor demanda tecnológica serían las siguientes:

Pericardiocentesis a la cabecera del paciente, con monitorización de electrocardiograma (ECG) exclusivamente. Se realiza con una aguja o cánula, por vía subxifoidea; el paciente estará colocado incorporado en la cama (45°). La aguja se introduce con un ángulo de unos 45° con la piel, dirigiéndola hacia el hombro izquierdo. Se avanza lentamente retirando periódicamente el mandril. Cuando se atraviesa el pericardio, se tiene la sensación de haber atravesado una membrana.

Pericardiocentesis con control ecocardiográfico además de ECG. Permite pericardiocentesis muy completas, con inserción de catéteres intrapericárdicos en lugar de agujas, que se pueden dejar durante un tiempo.

- Cuando el taponamiento no se soluciona con la pericardiocentesis o recidiva tras la misma, hay que practicar drenaje quirúrgico. Éste puede ser el tratamiento inicial de elección en caso de sospechar una etiología específica como la tuberculosa, ya que permite la toma de biopsia del pericardio o la bacteriana.

EVOLUCIÓN

La evolución de la pericarditis suele ser hacia la resolución completa en el plazo de 2-4 semanas.

La recurrencia de la pericarditis (pericarditis recurrente) y el derrame es posible en todas las formas etiológicas, bien por recurrencia de la enfermedad causante (séptica, tuberculosa, reumática...) o de forma independiente al curso de la enfermedad, y se produce en un 10-30% de los casos. En pediatría, la pericarditis vírica, la idiopática y el síndrome post-pericardiotomía son las causas más frecuentes de pericarditis recurrente. El manejo de la recurrencia debe ser igual al del brote inicial, valorando bien si éste fue el correcto o no (periodo de reposo demasiado corto, dosis bajas de antiinflamatorios o

interrupción prematura de éstos).

Por lo general, se trata de una sola recidiva en las primeras semanas tras el brote inicial, pero algunos pacientes pueden presentar brotes repetidos durante meses o años. Cuando la recidiva aparece al intentar suprimir el tratamiento antiinflamatorio o con un intervalo de tiempo inferior a 6 semanas desde el inicio del brote inicial, se define como pericarditis incesante. Se desconoce la causa de esta evolución crónica de difícil manejo terapéutico, pero se cree que se debe a una respuesta autoinmune.

La pericarditis constrictiva se debe a un proceso fibrótico que abarca ambas hojas pericárdicas y que impide el llenado del corazón; es poco frecuente y de causa desconocida. La fisiopatología es similar a la del taponamiento, de instauración lenta. Puede asociarse con cualquier tipo de pericarditis aguda, pero es una complicación frecuente en la pericarditis tuberculosa y en la bacteriana, en las que puede ser de aparición bastante precoz (a las pocas semanas o en los primeros 3 meses tras la fase aguda). En algunos pacientes incluso puede aparecer constricción ya durante la fase aguda.

En la pericarditis constrictiva leve o moderada se mantendrá una actitud expectante con controles clínicos frecuentes, ya que puede retroceder espontáneamente o con tratamiento corticoideo. Si aparecen signos de insuficiencia cardíaca derecha severa o persistentes, la pericardiectomía es el tratamiento de elección.

FORMAS ESPECÍFICAS DE PERICARDITIS

Pericarditis aguda viral o idiopática

Se engloban en el mismo apartado, ya que clínicamente son indistinguibles y es posible que muchas pericarditis idiopáticas sean causadas por infecciones virales no identificadas.

Habitualmente los cultivos de virus en el líquido no son positivos, y se presume la causa viral por un título en aumento de los anticuerpos séricos o por exclusión. Con frecuencia está precedida por una infección de las vías altas, y suele ser de curso benigno y autolimitado, con resolución completa en 3-4 semanas. Los derrames pleurales asociados son frecuentes.

En algunos niños es posible la recurrencia (15-25% de los casos), después de suspender el tratamiento, de forma inmediata o con un intervalo asintomático de semanas o meses. Se postula que las recurrencias son debidas a mecanismos

inmunológicos. Puede complicarse con miocarditis asociada, taponamiento cardíaco y, muy raramente, por el desarrollo de pericarditis constrictiva.

Pericarditis bacteriana o purulenta

Suele estar relacionada con una infección grave (neumonía con empiema, meningitis, osteomielitis, septicemia, absceso hepático) con progresión de la infección por extensión o, menos frecuentemente, por vía hematógena al pericardio. Actualmente, el microorganismo más frecuente es el *S. aureus*, seguido del *H. influenzae* de tipo b. Los niños con pericarditis bacteriana suelen presentar un estado tóxico con fiebre alta.

La rigidez del pericardio debida al engrosamiento del mismo puede hacer que un pequeño derrame dé lugar a una rápida progresión al taponamiento, así como a la pericarditis constrictiva. Es importante, por ello, la sospecha diagnóstica ante todo niño con clínica de taponamiento y sepsis para realizar un rápido y adecuado tratamiento.

La pericardiocentesis proporciona el diagnóstico y un rápido alivio con sólo extraer una pequeña cantidad de líquido, aunque el tratamiento definitivo suele requerir pericardiectomía parcial quirúrgica (ventana pericárdica).

Debe iniciarse antibioterapia de amplio espectro enérgica hasta determinar el germen, con cloxacilina o vancomicina asociadas a cefotaxima o ceftriaxona, y debe mantenerse el tratamiento entre 6 y 8 semanas.

La curva febril, la VSG y la serie blanca son los parámetros que se utilizan para valorar la respuesta al tratamiento.

Pericarditis tuberculosa

Es poco frecuente en nuestro medio. Se cree que supone un 1-4% de las infecciones por *Mycobacterium tuberculosis*. Se produce por invasión directa o por extensión linfática desde los ganglios mediastínicos. La pericarditis puede ser aguda o subaguda, con formación de granulomas en el tejido pericárdico con gran tendencia a pericarditis constrictiva. La evolución al taponamiento también es frecuente.

El diagnóstico de pericarditis tuberculosa resulta a veces dificultoso. No debe basarse en la presencia de pericarditis en un paciente con Mantoux positivo exclusivamente. Por lo general, el diagnóstico se realiza en el contexto de

pacientes con pericarditis a los que se diagnostica tuberculosis extracardíaca y se aísla el bacilo fuera del pericardio. Un elevado título de ADA en el líquido pleural o pericárdico es también muy sugerente de pericarditis tuberculosa. El diagnóstico definitivo requiere aislar el bacilo en líquido pericárdico o biopsia pericárdica. En los últimos años, la determinación de PCR frente a *M. tuberculosis* en líquido o tejido pericárdico ha permitido un rendimiento diagnóstico mayor y más precoz.

Además del tratamiento antibiótico con tres o cuatro fármacos durante 9-18 meses, los esteroides parecen ser eficaces para reducir la inflamación en la fase aguda y mejorar la evolución.

Síndrome post-pericardiotomía

Se presenta habitualmente de 2 a 6 semanas después de la cirugía cardíaca con apertura de pericardio, aunque se han descrito casos de inicio a las 12 o 52 semanas. Es más frecuente en cirugía cardíaca en niños, y en la cirugía de la comunicación interauricular, comunicación interventricular y de la tetralogía de Fallot.

Suele ser un cuadro autolimitado en 2-3 semanas. Se caracteriza por fiebre, dolor torácico, disnea y derrame pericárdico. Algunos casos progresan a taponamiento. Se acompaña de leucocitosis y elevación de parámetros inflamatorios. Es frecuente también la presencia de signos y síntomas de afectación pleural (izquierda sobre todo) concomitante.

La patogenia es desconocida, pero se postulan mecanismos inmunológicos no bien conocidos. La recidiva es infrecuente, pero cuando se produce puede tener lugar meses o años después del evento inicial.

La medida de tratamiento más importante es el reposo en cama hasta la desaparición de la fiebre. Se administrarán AINE para el dolor, y en

casos de afectación importante puede indicarse prednisona (2 mg/kg/día, 3 semanas, con reducción progresiva). En caso de taponamiento, está indicada la pericardiocentesis.

Pericarditis neoplásica

La pericarditis neoplásica es resultado de la extensión pericárdica directa, la metástasis linfática de un tumor intratorácico primario o la diseminación hematógena de una neoplasia. En niños, los tumores que metastatizan en el pericardio con más frecuencia son las leucemias y los linfomas.

El diagnóstico se basa en la identificación de células malignas en el líquido pericárdico.

El taponamiento cardíaco es frecuente, y los derrames recurrentes constituyen a veces un problema terapéutico. Los pacientes con taponamiento deben ser sometidos a pericardiocentesis, dejando un catéter intrapericárdico para drenaje conectado a un sistema de aspiración en vacío. La persistencia de derrame importante después de 7 días o la recidiva tras retirada del drenaje con taponamiento pueden ser indicación de instilación de tetraciclina en la cavidad pericárdica.

Bibliografía

Díaz, Márquez, Núñez, Sandoval. *Cardiomiopatías en edad pediátrica. En: Cardiología Pediátrica. Gabriel F. Góngora. Piñeiro, Bustamante Labarta, Guevara, Migliore, Roisinblit. Eco cardiografía para la toma de decisiones. Somoza FJ, Marino B. Cardiopatías congénitas.*

***Dra. M. Quayat Revisora**

Cardióloga infantil, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez CABA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA INFANCIA

Hospital General Manuel Belgrano de San Martín



Dra. María Sol Cicero Moroni

Jefa de Residentes

Dr. Álvaro Enrique Pinto Merett

Jefe de Residentes

Dr. Daniel José Mogues*

Revisor

Sumario

La hipertensión arterial es una patología subdiagnosticada en pediatría que puede llevar a complicaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Evidencia aumento de la prevalencia de la hipertensión arterial primaria por la epidemia de obesidad

La prevención primaria con la toma periódica de tensión arterial en el control de salud, la eliminación de factores de riesgo y la prevención secundaria implementando cambios higiénico-dietéticos son medidas alcanzables por toda la población.

Caso clínico

Paciente masculino de 12 años de edad, con antecedentes a destacar que concurre a consultorio de seguimiento para realizar control de salud.

Al examen físico presenta peso de 62 kg (Pc >97), talla 148 cm (Pc 50), IMC 28.3 (Pc >97, Z score entre +2 y +3), perímetro de cintura 80.5 cm. TA 124/82 mmHg (Pc 95 TAS 123 Pc 95 TAD 81). Tanner estadio 3. Sin otros datos a destacar al examen físico.

Reflexión

¿Qué le llama la atención de los datos antropométricos?

Comentario

El paciente presenta una antropometría alterada, con un IMC con Z score entre +2 y +3 que según la clasificación es obesidad. Un índice de cintura/talla mayor a 0,5 y una TA por encima de Pc 95 para sexo, edad y talla.

Entre los antecedentes familiares el padre es hipertenso y diabético tipo 2. No hay antecedentes de patología renal ni de enfermedad coronaria. Los padres refieren que hace varios años el niño presenta sobrepeso, que no come verduras y que permanece horas delante de pantallas. Buen rendimiento escolar y desarrollo neuromadurativo acorde a edad.

Si bien en la infancia la causa más frecuente de la hipertensión es la secundaria, en el caso de nuestro paciente lo más probable es que sea primaria debida a la obesidad que presenta. Tiene además de la tensión arterial elevada un perímetro de cintura aumentado; ambos son criterios para el síndrome metabólico por lo

que deberíamos hacer algunas determinaciones como glucemia en ayunas, triglicéridos y medición del colesterol HDL para decidir si podríamos catalogarlo como tal. En principio las medidas terapéuticas serían fomentar los cambios de hábitos higiénico-dietéticos y controlarlo lo más pronto que se pueda con los resultados de los exámenes solicitados (lipidograma, glucemia, hemograma, ecografía abdominal para descartar hígado graso).

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PEDIATRÍA

Generalidades

En la última década la prevalencia de hipertensión arterial en pediatría ha aumentado notablemente, sobre todo por la presencia de HTA primaria en pacientes con obesidad.

Es importante tenerla en cuenta ya que es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada, y además es importante pensarla por las complicaciones y consecuencias que puede tener a largo plazo.

En el 2017 se ha realizado una revisión sistemática de los niños y adolescentes escolarizados con tensión arterial elevada que arrojó como resultados mayor prevalencia en mayores de 10 años y en varones; con una prevalencia total entre 5 y 20 años del 7,35%, y los siguientes factores de riesgo principales: sedentarismo, sobrepeso, obesidad abdominal, obesidad y tabaquismo.

La hipertensión puede ser primaria (4,5-13%) o secundaria, siendo la causa más frecuente la renal. Cuanto más pequeño sea el paciente con cifras elevadas de TA, mayor será la probabilidad de que su origen sea secundario.

¿A quiénes se les debe tomar la tensión arterial?

Los niños mayores de 3 años deberían tener mediciones periódicas de TA, mientras que a los menores de esa edad se les debería tomar si existieran hematuria y/o proteinuria, malformaciones urológicas o enfermedades renales, historia familiar de enfermedad renal congénita, BPN, RNPT que haya requerido internación en UTIN, ITU a repetición, tumores, cardiopatía congénita, ingesta de fármacos que aumenten la TA, hipertensión endocraneana. Otras patologías como el síndrome nefrítico, el nefrótico y la Púrpura de Schönlein Henoch pueden cursar también con hipertensión transitoria, por lo que

en estos pacientes deben realizarse mediciones de presión arterial.

En los pacientes normotensos deberá controlarse cada 2 años y en aquellos con TA aumentada sin daño de órgano blanco, en forma anual, manejándose mientras tanto con medidas higiénico-dietéticas.

¿Cómo se realiza una adecuada toma de la presión arterial?

Pueden utilizarse tanto el método auscultatorio como el oscilométrico con aparatos electrónicos validados. Cabe destacar que en caso de detectarse cifras elevadas de TA con este último método DEBE verificarse con el manual, ya que en muchas oportunidades las cifras ofrecidas por los aparatos son superestimadas.

Existen manguitos pediátricos de diferentes tamaños, tanto en ancho como en largo. Lo recomendable es que el ancho abarque el 40% de la circunferencia del brazo - medida en el punto medio del acromion al olecranon- y que la longitud cubra el 100% de dicha circunferencia.

En caso de no contar con el manguito adecuado para el paciente ha de utilizarse el inmediato superior, ya que los más pequeños podrían arrojar cifras elevadas.



Fuente: Congreso de Actualización Pediatría AEP, 2019

Para la medición idealmente el paciente debería permanecer sentado y relajado durante al menos 3 a 5 minutos y luego medir la PA 3 veces en intervalos de 3 minutos, realizando la media de las dos últimas. Inicialmente tiene que medirse en los 2 brazos y, en caso de discordancia, se elegirá el brazo con el valor superior como referencia.

¿Cuándo se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial?

-TAS o TAD mayor a Pc 95 para edad y percentilo de talla en por lo menos 3 oportunidades

-Adolescentes con valores superiores o iguales a 140/90 mmHg en por lo menos 3 oportunidades.

Clasificación de la hipertensión arterial

Clasificación de la HTA según las guías europeas

Categoría	0-15 años	≥16 años
Normal	<P90	<130/85 mmHg
Normal-alta	≥P90 a <P95	130-139/85-89 mmHg
HTA	≥P95	>140/90 mmHg
HTA grado 1	≥P95 a P99 + 5 mmHg	140-159/90-99 mmHg
HTA grado 2	>P99 + 5 mmHg	160-179/100-109 mmHg
HTA sistólica aislada	PAS ≥P95 y PAD <P90	≥140/<90 mmHg

P: percentil; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica.

Fuente: Congreso de Actualización Pediatría AEP, 2019

Causas de HTA más frecuentes por grupos de edad

Menores de 1 mes

- Trombosis de la arteria renal (tras canalización de arteria umbilical)
- Coartación de aorta
- Lesión renal congénita
- Displasia broncopulmonar

Entre 1 mes y 6 años

- Enfermedad parenquimatosa renal (glomerulonefritis, cicatrices renales, displasia renal, enfermedad poliquística)
- Coartación de aorta
- Estenosis de la arteria renal (HTA renovascular)

Entre 6 y 10 años

- Enfermedad parenquimatosa renal
- Estenosis de la arteria renal
- HTA esencial

Entre 10 y 18 años

- HTA esencial
- Enfermedad parenquimatosa renal
- Estenosis de la arteria renal

Fuente: Asociación Española de Pediatría, 2014

Si la TA se encontrara entre percentilo 95 y 99 debería repetirse al mes, mientras que si fuera mayor al percentilo 99 la indicación es que sea valorado rápidamente por un especialista.

Abordaje clínico

INTERROGATORIO: indagar sobre antecedentes familiares y personales, factores de riesgo (hábitos higiénico-dietéticos, tabaquismo, alcohol, ingesta fármacos, anamnesis del sueño, síntomas sugestivos de HTA secundaria como disuria, sed, poliuria, nicturia, hematuria, edema, palpitaciones, virilización, amenorrea primaria-, síntomas sugestivos de daño orgánico -cefalea, epistaxis, vértigo, alteraciones visuales, parálisis facial, convulsiones, ictus, disnea-).

EXAMEN FÍSICO: peso, talla, IMC, rasgos de síndromes asociados a HTA, TA y pulsos en 4 miembros, auscultación cardíaca, palpación de masas a nivel abdominal.

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Como se mencionó anteriormente en los niños la hipertensión suele ser secundaria, pero en los últimos años la primaria ha aumentado notablemente su prevalencia debido al gran número de pacientes con sobrepeso y obesidad.

VALORACIÓN DEL DAÑO DE ÓRGANO BLANCO

- corazón: ecocardiograma para descartar hipertrofia del ventrículo izquierdo; valorar microalbuminuria, función renal y filtrado glomerular
- vasos sanguíneos: evaluar si existe aumento del grosor de la íntima media carotídea
- cerebro: existe riesgo de convulsiones, ictus, alteraciones visuales. Si se sospecha daño deberá realizarse un EEG
- ojos: realizar oftalmoscopia en busca de retinopatía hipertensiva. 30-50% de los niños con HTA presenta cambios retinianos.

Exámenes complementarios

TODOS deben realizarse hemograma, función renal, ionograma, glucemia, perfil lipídico, orina, proteinuria y microalbuminuria, ecografía renal, radiografía de tórax, ECG y ecocardiograma.

Según el caso será necesario valorar la actividad Renina-Angiotensina-Aldosterona, realizar eco Doppler color renal (antes de iniciar tratamiento con enalapril o ante la sospecha de estenosis de arteria renal como causa de la HTA),

dosar las catecolaminas, realizar centello con DMSA.

¿Cuándo realizar un Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial?

- en pacientes que requieran iniciar tratamiento farmacológico
- pacientes con diabetes tipo 1, nefropatía crónica, trasplante renal, hepático y/o cardíaco
- en evaluación de HTA refractaria
- control PA en niños con daño orgánico
- síntomas hipotensión
- confirmación HTA cuando la TA se mantiene elevada por 1 año o más o cuando se encuentra en estadio 1 por 3 oportunidades

TRATAMIENTO

Las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales y constituyen uno de los pilares del tratamiento.

Diversos estudios han concluido que en grupos que realizaban actividad física versus otros que no los registros de TA disminuían notablemente; al igual que aquellos que disminuían el consumo de sodio contra los que no, con una reducción significativa de los valores de TA en los primeros.

La dieta recomendada se trata de la DASH (Dietary approaches to stop HTA), rica en frutas, vegetales y granos, con consumo reducido de azúcar, sodio y grasas.

Terapia farmacológica

Las indicaciones son:

- HTA con síntomas
- daño de órgano blanco
- estadio 2
- TA > Pc90 en coexistencia de diabetes o enfermedad renal crónica
- HTA estadio 1 por más de 6 meses.

En un principio la terapia debería ser con un único fármaco (IECA, ARA II, bloqueantes cálcicos) a bajas dosis, con aumento de la misma si tras 4 a 8 semanas los valores no descendieron. Recién cuando haya transcurrido un tiempo prudencial y se haya aumentado la monodroga podrá agregarse otro medicamento con un mecanismo de acción diferente.

Aquellos pacientes que requieran monitorización y vigilancia estrechas, los que presenten emergencia hipertensiva acompañada de dis-

función orgánica aguda que requiera tratamiento urgente endovenoso deberán internarse.

¿Cuál es la TA objetivo?

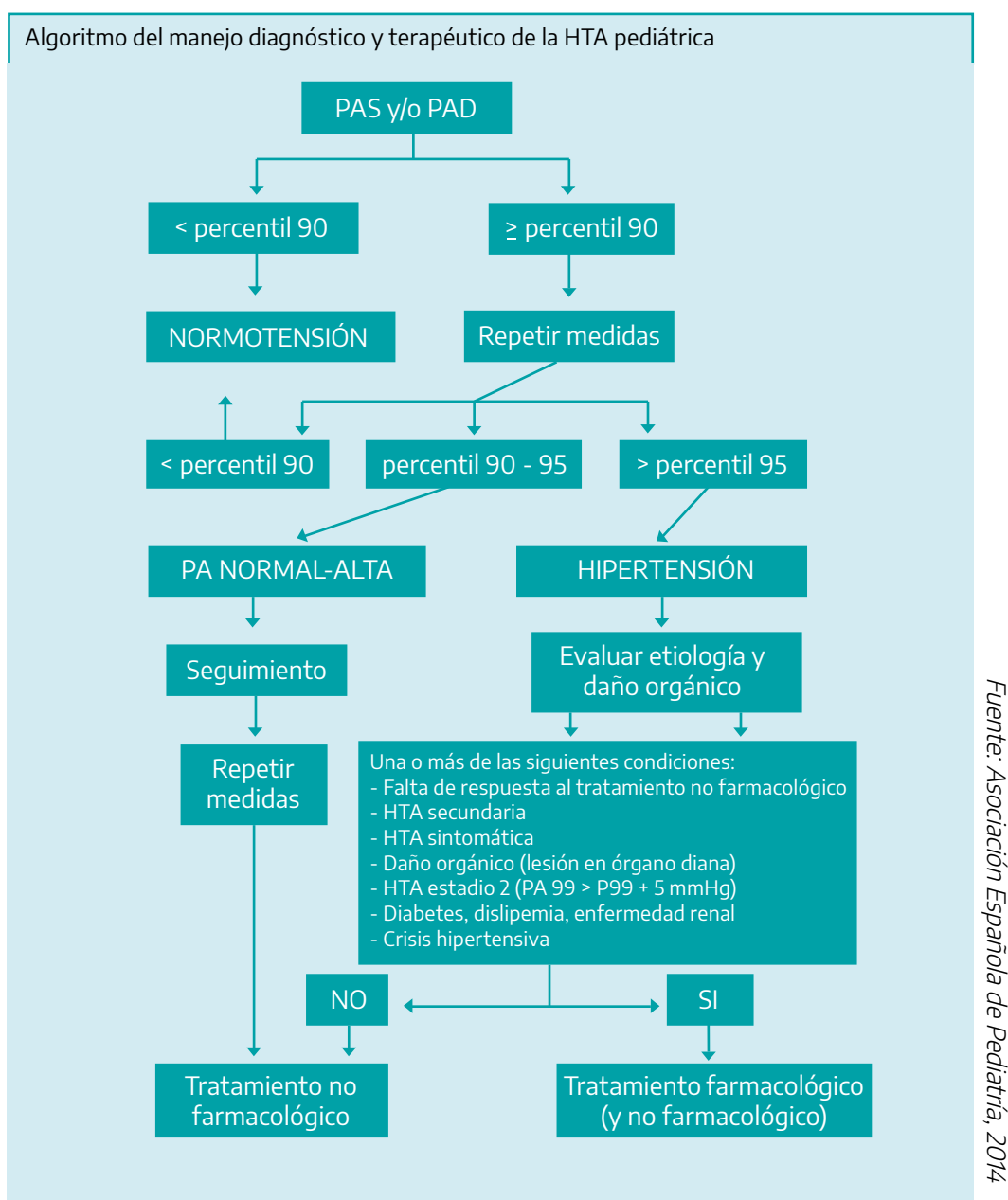
La misma dependerá del sexo, edad y talla del paciente, como también de la existencia de comorbilidades.

Se espera que se logren cifras de TA por debajo del percentilo 90, y en caso de que sean nefrópatas, o presenten proteinuria, menores al 75 y al 50 respectivamente.

ALGORITMO DEL MANEJO EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMENTARIO DEL ESPECIALISTA

Desde el inicio de mi práctica como pediatra

y nefrólogo infantil hasta la actualidad ha sido notable cómo a lo largo de los años ha aumentado el número de niños con hipertensión arterial esencial y a edades cada vez más tempranas. Esto debe hacernos pensar en varias cosas, sobre todo en la importancia de la prevención primaria a través de medidas higiénico-dietéticas, con fomento de la actividad física y regulación de la ingesta de sodio desde el inicio de la alimentación complementaria. También cabe destacar la asociación de la hipertensión arterial con el síndrome metabólico, por lo que una vez detectada la tensión arterial elevada es mandatorio evaluar otros parámetros para determinar si el paciente se encuentra también cursando dicha patología.



En cuanto a la actividad física, la misma actúa como beta bloqueante natural. La presión arterial depende de la resistencia vascular periférica y del gasto cardíaco y éste depende a su vez del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Aquellas personas que realizan ejercicio habitualmente suelen presentar frecuencias cardíacas bajas en reposo logrando disminuir entre 4 y 9 mm Hg las cifras de tensión arterial.

En relación a la ingesta de sodio, mientras que lo ideal sería una dieta de hasta 2,3 gramos día (equivalentes a 5,8 gramos de cloruro de sodio) en la mayoría de los países el consumo se eleva a 6-12 gramos diarios. Hay evidencia de que en poblaciones con bajo consumo (menos de 3 gramos) la prevalencia de hipertensión arterial es mucho menor y no aumenta con la edad en comparación con otros grupos con ingestas mayores. Esto está directamente relacionado con la función de los riñones de excretar agua y sal regulando así el volumen de sangre circulante y, por ende, la tensión arterial.

Resumiendo, la hipertensión arterial es una enfermedad con múltiples complicaciones. Como pediatras es importante hacer hincapié desde el primer contacto con las familias en la importancia de tener hábitos de vida saludables, con una dieta equilibrada, con ingesta regulada de sodio, evitando los ultraprocesados siempre que se pueda y fomentando la actividad física.

Bibliografía

- Antón Gamero M. ¿Hay que medir la presión arterial en niños? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hipertensión arterial en niños y adolescentes en Atención Primaria. En: Congreso de Actualización Pediatría 2019. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2019.
- De la Cerda Ojeda F., Herrero Hernando, C., AEPED HTA en niños y adolescentes. *Protoc diagn ter pediatr*, 2014; 1: 171-189
- Díaz A., Calandra L., PA elevada en niños y adolescentes escolarizados de Argentina en los últimos 25 años: revisión sistemática de estudios observacionales. *Arch Argent. Pediatr*, 2017; 115 (1): 5-11.
- Dionne J. y col., Guidelines for the diagnosis, assesment, prevention and treatment of pediatric hypertension. *Canadian Journal of Cardiology*, 2017; 33 (5): 577-585
- Gupta Malhotra M y col., Essential hypertension versus secondary hypertension among children. *American Journal of Hypertension*, 2015; 28 (1): 73-80
- Matossian D., Pediatric hypertension. *Pediatric annals*, 2018; 47 (12): e499-e503
- Saieh C, Lagomarsino E., Hipertensión arterial y consumo de sal en pediatría. *Rev Chil Pediatr*, 2009; 80 (1): 11-20.
- Santi M. y col., Arterial hypertension in children. *Current opinion in Cardiology*, 2015; 30 (4): 403-410.
- Tiu Andrew, Primary pediatric hypertension: current understanding and emerging concepts. *Current hypertension reports*, 2017; 19 (9): 70.

Ingesta diaria de sodio recomendada según edad

Edad	Ingesta de sodio por día (mg)
0 a 6 meses	120
7 a 12 meses	370
1 a 3 años	1 000
4 a 8 años	1 200
9 o más años	1 500

Correlaciones en miligramos para el sodio y en gramos para la sal

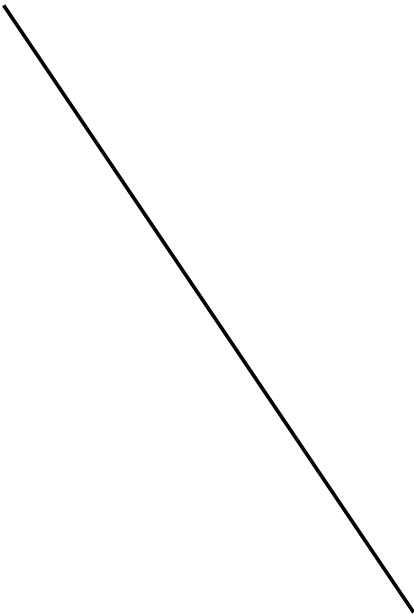
Sodio en mg	Sal en g
500	1,25
1 500	3,75
2 000	5,0
2 300	5,8
2 400	6,0
3 000	7,5
4 000	10,0

Fuente: Hipertensión arterial y consumo de sal en pediatría

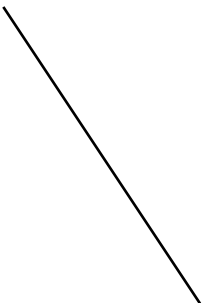
*Dr. Daniel José Mogues

Nefrólogo infantil formado en el Hospital de Niños de San Justo.

Ex jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Manuel Belgrano de San Martín.



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **H**

SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría



Dra. Paola Basualdo

Instructora de Residentes

Dra. Iara Chocron

Jefa de Residentes

Dra. Carla Camacho

Dra. Leila Menta

Residentes

Dra. Julieta Ciabattoni

Dra. María Laura Andornino

Dr. León Sandy Chaparro

Pediatras

Dra. Gabriela Arakelian*

Revisora

Sumario

Es la causa más frecuente de Injuria renal aguda (IRA) en lactantes y niños de primera infancia, siendo la segunda causa de trasplante renal en niños en Argentina.

En Argentina, es una patología endémica, se producen entre 300 y 500 casos nuevos por año, con una tasa de incidencia anual promedio de 1 caso cada 100.000 habitantes. El año 2008 presentó el número más alto de casos del período 2005-2013 (543), mientras que 2013 presentó el más bajo (319). A partir de 2010 se verifica una disminución en el número de casos registrados.

En la actualidad, la principal etiología es la infección gastrointestinal por cepa de E. Coli productoras de toxina Shiga. El reservorio son diferentes animales (vaca, ciervos, ovejas, caballo, perros, aves y moscas) y la fuente de contagio es a través de leche, agua, frutas, vegetales, carnes y persona-persona. Posee un período de incubación de una semana aproximadamente

Situación clínica

Sofía de 4 años de edad consulta por presentar

cuadro de 11 días de evolución de deposiciones desligadas y disentería, se asocia a fiebre, dolor abdominal tipo cólico, presenta decaimiento, oliguria y palidez generalizada, por lo que consulta y se decide su internación.

Paciente sin antecedentes de relevancia, calendario de vacunación completo.

A su ingreso se encuentra taquicárdica, taquipneica, afebril, somnolienta con palidez mucocutánea. Cardiopulmonar normal. Abdomen depresible, doloroso, sin signos de defensa ni visceromegalias, RHA+. Ritmo diurético disminuido.

Se solicitan estudios complementarios: Hemograma GB 27.400 N70% con 3% cayados/ Hb 6.8 g/dl / Hto 23%/ Plaquetas 15.000/ Coagulo TP 92 KPTT 26/Creatinina 5 mg/dl/ Urea 1.6 mg/dl/ Ácido Úrico 14.9 mg/dl/ BT 0.92 mg/dl/ BD 0.24 mg/dl/ BI 0.68 mg/dl/ TGP 90 U/L/ TGO 61 U/L/ FAL 380 U/L/ Glucemia 61 mg/dl/ LDH 5982 U/L/ Ca 7.6 mg/dl/ P 4.92 mg/dl/ Amilasa 262 U/L/ prot totales 56.7 g/dl. Interpretándose como leucocitosis con fórmulas inmaduras, anemia, plaquetopenia, insuficiencia renal aguda. Se observa marcada anisopoiquilocitosis, abundantes

esquistocitos y esferocitos (en frotis).

TRO: pH 5, glucosuria ++ y proteinuria ++.

Se realiza radiografía toraco-abdominal sin particularidades.

Se interpreta el cuadro como Síndrome Urémico Hemolítico.

Se realiza TGRD 10 ml/kg. Se indica fluido terapia con balance estricto hidroelectrolítico y dieta, la paciente permanece en anuria por lo que requirió diálisis peritoneal, restableciéndose el ritmo diurético al octavo día. Por presentar buena evolución clínica se decide el alta con controles posteriores de manera ambulatoria por el servicio de nuestro hospital.

Reflexiones

¿Cuáles son los síntomas cardinales que podemos identificar en un primer momento?

¿Qué hacer frente a un SUH?

¿Cuáles son los criterios de diálisis?

INTRODUCCIÓN

El SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH) es una entidad clínica y anatomopatológica caracterizada por la triada:

- ✓ ANEMIA HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA
- ✓ TROMBOCITOPENIA
- ✓ INJURIA RENAL AGUDA

DIAGNÓSTICO

Clínico: antecedente de gastroenteritis (diarrea sanguinolenta en los dos tercios de los casos, como consecuencia del daño local en los vasos del colon producido por la toxina liberada), seguido por la triada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y fallo renal agudo, de instalación brusca en un paciente previamente sano. Comienza 4 días luego del comienzo de la diarrea (1-10 días), cuando ésta comienza a mejorar. La palidez y oliguria preceden el comienzo clínico del SUH. Algunos pacientes se muestran deshidratados e hipovolémicos.

Hematología: Anemia hemolítica microangiopática, debida a injuria endotelial. Pacientes que requieren múltiples transfusiones.

Hemostasia: actividad normal o alta del factor VIII, factor V, fibrinógeno, monómeros de la

fibrina y productos de degradación del fibrinógeno. La tercera parte de los pacientes tienen acortamiento del tiempo parcial de tromboplastina.

Química: Deterioro de la función renal (creatinina en suero mayor que el límite normal para edad). Niveles en suero elevados de la enzima láctico-deshidrogenasa y haptoglobina descendida confirman la hemólisis intravascular.

Orina: La severidad del compromiso renal varía desde la presencia de microhematuria y proteinuria hasta el fallo renal severo con oligoanuria.

Medio interno: el enfermo grave mostrará las complicaciones de los trastornos metabólicos, que incluyen hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipocalcemia e hiponatremia o hipernatremia.

Bacteriología: Aislamiento de ECEH en materia fecal, Detección de la toxina en materia fecal (ELISA), PCR.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- 1) Invaginación intestinal: en los casos con predominio del cuadro colónico (dolor abdominal intenso, deposiciones diarreicas con sangre, abdomen distendido, placa abdominal que sugiere a veces obstrucción)
- 2) Sepsis
- 3) Meningitis
- 4) Deshidratación con IRA
- 5) Púrpura trombótica trombocitopénica

TRATAMIENTO

Manejo general:

- Todo paciente con sospecha de SUH tiene criterio de internación.
- Ante un caso de SUH efectuar la notificación obligatoria, inmediata e individualizada al Ministerio de Salud.
- Se recomienda la internación del paciente con SUH en aislamiento para evitar la diseminación de la ECEH.
- Se sugiere no indicar medicación anti-peristáltica o anticolinérgica dado que aumenta el riesgo de complicaciones sistémicas.

- La utilización de antibióticos (ATB) no tiene acción protectora para el desarrollo de SUH ni altera el curso de la diarrea aguda, por lo que se recomienda no indicar ATB en niños < 10 años ante la sospecha de ECEH y/o SUH y suspenderlos si se utilizaron previamente a los resultados microbiológicos.
- Pueden considerarse factores de mal pronóstico a largo plazo la presencia de afectación severa del SNC, prolapso rectal, infartos colónicos, necrosis intestinal, colitis hemorrágica, o leucocitosis con neutrofilia al inicio de la enfermedad y la prolongación de los días de anuria.

Aporte hídrico:

Valorar el estado de hidratación del paciente al ingreso mediante examen físico y control de signos vitales: peso, tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

En pacientes con shock hipovolémico, expandir con solución fisiológica a 20 ml/kg en 5 a 20 minutos a fin de reconstituir el volumen intravascular.

Repetir la expansión ante la falta de mejoría si fuese necesario. Con la mejoría disminuir goteo a 10 ml/kg hasta normohidratar.

En pacientes con deshidratación leve a moderada reponer déficit de fluidos con SF a 10 ml/kg hasta la normohidratación.

Ante la presencia de hipertensión arterial o sobrecarga de volumen indicar restricción hídrica.

En el paciente normohidratado con tolerancia a la vía oral comenzar aporte enteral.

Revalorar en forma permanente la respuesta a la infusión de fluidos con examen físico, signos vitales y diuresis.

Manejo de electrolitos:

Sodio: Es frecuente la hiponatremia ($\text{Na} < 135$ mEq/l). En el estadio inicial del SUH suele ser real por pérdidas digestivas y se corrige con aporte de Na. Al instalarse el daño parenquimatoso es de causa dilucional y se indica restricción hidrosalina.

Potasio: La hiperkalemia ($\text{K} \text{ sérico} > 5.5$ mEq/l) es frecuente y la urgencia de su tratamiento depende del nivel sérico y las alteraciones en el ECG. En pacientes con deterioro de la función renal indicar aporte restringido de K.

Fósforo: En niños con SUH e IRA la hiperfosfa-

temia es frecuente. El valor de fósforo sérico a alcanzar es de 4 a 6 mg/dl en niños de 1 a 12 años y de 3.5 a 5.5 mg/dl en adolescentes. Se recomienda restricción del fósforo en la dieta e indicación de quelantes del fósforo vía oral (V.O.):

Carbonato de calcio VO a 8 g/1.73 m² de superficie corporal. Evitar la administración de compuestos con aluminio y antiácidos que contengan Mg o citrato.

Calcio: La hipocalcemia es frecuente en la IRA. En presencia de acidosis metabólica la fracción de calcio iónico aumenta. El aporte de bicarbonato para corrección de la acidosis metabólica puede disminuir la concentración de calcio iónico y precipitar síntomas de hipocalcemia. Si la hipocalcemia es sintomática y/o se requiere corrección con bicarbonato EV para tratar la hiperkalemia, se recomienda administrar gluconato de calcio al 10% (90 mg de Ca elemental cada 10 ml EV) a 1ml/kg (dosis máxima: 1-2 g) en 30 a 60 minutos con monitoreo ECG.

Manejo de la acidosis:

La acidosis metabólica es también frecuente. Se deben mantener valores:

Bicarbonato sérico de 22-24 mEq/l
pH >7.20.

En el paciente con IRA sin sobrecarga de volumen y sin criterios de diálisis indicar aporte de bicarbonato para corrección del déficit excepto en casos de acidosis leve.

La acidosis metabólica con hipervolemia y/o hipernatremia tiene indicación de diálisis.

Corrección de la anemia:

Se realiza transfusión con glóbulos rojos filtrados en caso de $\text{Hb} < 7$ g/dl, a fin de evitar sobrecarga de volumen, a 10 a 15 ml/kg.

En pacientes con Hb entre 7-10 g/dl puede considerarse la transfusión cuando hay signos, síntomas o evidencia objetiva de incapacidad de satisfacer la demanda tisular de O₂.

Si el paciente requiriese diálisis, indicar la transfusión durante la diálisis para minimizar riesgo de hipervolemia e hiperkalemia.

Trombocitopenia:

La transfusión profiláctica de plaquetas no está indicada.

En el paciente con plaquetopenia $\leq 50.000/\text{mm}^3$ que requiera procedimiento invasivo indicar infusión de plaquetas.

Nutrición:

Fijar una meta calórica no $< 120 \text{ cal/kg}$ en lactantes y de $1300\text{-}1600 \text{ cal/día}$ en niños mayores.

Administrar un aporte proteico no menor a las recomendaciones dietéticas para edad con por lo menos el 70% del mismo con proteínas de alto valor biológico.

Restringir el aporte de sodio, potasio y fósforo.

Utilizar de preferencia la VO, de ser necesario utilizar SNG.

Evitar restricción de la ingesta proteica con el objeto de prevenir o retrasar el inicio de la diálisis.

Manejo de la hipertensión arterial:

La hipertensión arterial se define como TAS y/o TAD $> \text{Pc } 95$ para sexo, edad y talla en 3 o más registros y suele ser por sobrecarga de volumen.

Se sugiere la indicación de bloqueantes cálcicos como tratamiento inicial:

Nifedipina (LP): $0.25 - 0.5 \text{ mg/kg/día}$ cada 12 a 24 hs (dosis máxima: 10 mg dosis)

Amlodipina: $0.1\text{-}0.5 \text{ mg/kg/día}$ cada 24 hs (dosis máxima: 10 mg/día)

No utilizar inhibidores de enzima de conversión (enalapril) dado el riesgo de reducción de la perfusión renal y agravamiento de la IRA.

Tratamiento de reemplazo de la función renal:

La elección de la terapia dialítica de reemplazo depende de la clínica y localización del paciente y de la disponibilidad y/o experiencia dialítica.

La diálisis peritoneal (DP) en forma manual intermitente o automatizada con cicladora es la terapia más utilizada en el paciente con SUH y fallo renal "aislado" sin compromiso de otros órganos o sistemas.

La hemodiálisis (HD) y las terapias de reemplazo continuo (hemodiafiltración-HDF) son cada vez son más indicadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Las indicaciones de diálisis son:

Signos de uremia: alteración del sensorio independientemente de la concentración de urea y/o creatinina en sangre.

Sobrecarga de volumen con manifestaciones

clínicas: edema agudo de pulmón y/o insuficiencia cardíaca y/o hipertensión arterial severa que no responden al tratamiento médico.

Acidosis metabólica grave ($\text{ph} \leq 7.20$) con o sin sobrecarga de volumen, especialmente en pacientes con oligoanuria.

Anomalías hidroelectrolíticas: hiperkalemia ($\text{K} > 7 \text{ mEq/l}$) o hipo/hipernatremia sin respuesta al tratamiento médico.

Necesidad de aporte nutricional en un niño con oligoanuria.

Aumento progresivo de los niveles de urea ($>160\text{-}200 \text{ mg/dl}$) si la recuperación de la función renal no es esperable. En lactantes considerar iniciar terapia de reemplazo con valores más bajos de urea y creatinina.

EVOLUCIÓN

Más del 90% de los enfermos sobrevive en la fase aguda si se aplica tratamiento radical de la IRA, la mayoría de ellos recupera la función renal normal; aunque se ha visto que en etapa aguda un 10 % queda con IRC. Se ha visto secuelas renales a largo plazo hasta en un 30% de los pacientes. El pronóstico depende de la duración del periodo oligúrico (grave con oligoanuria 10 días) y de la gravedad del compromiso encefálico.

El pronóstico a corto plazo del SUH ha mejorado considerablemente en los últimos años, especialmente debido al mejor manejo de la falla renal aguda.

CRITERIOS DE ALTA

En la etapa aguda:

Hematocrito Estable: generalmente presentan hematocritos menores a los esperados para la edad, pero sin síntomas de anemia y con un último episodio de hemólisis 5-7 días antes del alta.

Manejo adecuado de agua y potasio: la gran mayoría presenta diuresis $>20\text{cc/kg/día}$ o poliuria en la fase de salida, por lo cual requieren aporte de potasio en forma de cloruro, según pérdidas urinarias y concentración de potasio sérico. Habitualmente, se observa disminución de la urea que alcanza, en la gran mayoría a los casos, valores normales al alta, no así la creatinina, que se mantiene en descenso, pero elevada en relación con la esperada para la edad. Cuando más prolongada fue la anuria, más lenta es la curva de descenso de creatinina.

SUH ATÍPICO

SECUNDARIO: La causa más frecuente es el SUH secundario a infección por *Streptococcus pneumoniae*. Otros agentes son el virus N1H155, y, en pacientes con trasplantes el citomegalovirus (CMV) y el virus parvo B1957. Con mucho menor frecuencia se lo describe asociado con drogas inmunosupresoras, agentes quimioterápicos, y anticonceptivos orales, clopidogrel y radiaciones ionizantes. También en trasplante de médula ósea, pareciendo estar relacionado a radioterapia o a infecciones luego del trasplante.

PRIMARIO: Sospecharlo siempre en neonatos y niños <6 meses con signos clínicos y de laboratorio de SUH (anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y deterioro de función renal) y ausencia de pródromo gastrointestinal. Considerar como signos característicos: falta de pródromo gastrointestinal, comienzo insidioso o brusco en formas post-infecciosas, evento desencadenante (infección de vía aérea superior, diarrea), ausencia de estacionalidad, evolución prolongada previa al desarrollo de IRA, hipertensión arterial severa, evolución con recaídas, fallo renal progresivo y permanente, afectación familiar.

Tratamiento SHUa

En todo paciente con SHUa realizar la derivación a un centro de tratamiento que cuente con Unidad de Nefrología Pediátrica y UCI.

Obtener las muestras de sangre para el diagnóstico siempre antes de la infusión de plasma o de plasmaféresis, excepto para el estudio de la expresión de proteína cofactor de membrana (MCP) en leucocitos de sangre periférica. Solicitar como estudios iniciales: CH50, C3, C4 y niveles séricos de trombomodulina.

La infusión de plaquetas sólo está indicada en caso de sangrado activo o procedimiento quirúrgico o invasivo en pacientes con recuento de plaquetas < 50.000/mm³.

Se recomienda comenzar empíricamente y precozmente con PLASMAFERESIS, con intercambio de 1 ½ volumen de plasma por sesión, y, en caso de no poder ser ésta realizado aporte de PFC, 10-20 ml/kg dentro de las 24 hs. de su sospecha diagnóstica. Asociar monitoreo hemodinámico estricto. Continuar en forma diaria

hasta normalización del recuento de plaquetas, LDH, haptoglobina y Hb y mejoría de la función renal. Espaciar a 5 y luego 3 veces a la semana durante 2 semanas cada intervalo, adecuando luego la frecuencia a la evolución clínica y déficit de factor.

En caso de infecciones, desencadenante frecuente de recaídas, se recomienda un estricto control clínico y de laboratorio para el diagnóstico y tratamiento precoz.

Se describe la utilidad del ECULIZUMAB (anticuerpo monoclonal) para el tratamiento para el SHUa familiares y recurrentes, se administra una vez por semana durante 5 semanas de manera endovenosa, es una terapia altamente costosa que evidencio resultados favorables para este tipo de alteraciones.

Bibliografía

- Avenidaño LH, Aljama García P, Rodríguez MA, Díaz DD, De los Ríos JE, Peláez SL. Nefrología Clínica. Madrid(España): Editorial Medica Panamericana;1997: 217-225.
- Cavagnaro FSM, Gana AJC, Lagomarsino EF, Vogel SA, Gederlini GH. Síndrome hemolítico urémico. Experiencia en un centro pediátrico. Rev Med Chile [online] julio 2005 [fecha de acceso 17 de Agosto de 2006] 133 (7): 781-787.
- Facundo JC, Delgado Ginebra Y, Castillo González D, Pavón Moran V, Gámez Pérez A, Sánchez Mallo LA. Síndrome hemolítico urémico. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter.[en línea] 2003 [fecha de acceso 9 de octubre de 2006]; 19 (2-3).
- Fayad A, Vallejo G, Canepa C. Síndrome urémico hemolítico. Experiencia en 1059 pacientes entre 1976 y 2000. Rev Hosp Niños BAires. 2001;43 (195): 288-294.
- Fernández-Brando RJ, Betancor LV, Mejías MP et al. Actualización en el tratamiento del Síndrome Urémico Hemolítico endémico. Patogénesis y tratamiento de la complicación sistémica más grave de infecciones por *Escherichia coli* productora de toxina Shiga. Medicina (Buenos Aires) 2011; 71: 383-389
- Hammermüller E, Macchi A. Síndrome urémico hemolítico (S.U.H.) Criterios de Atención.Hosp.De Pediatría Prof Dr J.P.Garrahan. 2000. vol.1: 75-80.
- Monteverde ML.GAP 2012: Manejo de la injuria renal Aguda en Niños. Monteverde ML.GAP 2014: Manejo del Síndrome Uremico Hemolitico.
- Morano J, Renteria MS, Silber R, Spizzini FD. Tratado de Pediatría. 3ra Ed. Buenos Aires: Editorial Atlantic; 2004: 939-942.
- Nelson WE, Behrman RE, Kligman RM, Arvin AM. Tratado de Pediatría. 15ta Ed. Santiago de Atahualtepec (México):McGraw-Hill Interamericana Editores S.A;1998:vol 2:1861-1862.
- Rivero MA, Paola NL, Etcheverría AI, Parma AE. *Escherichia coli* enterohemorrágica y Síndrome urémico hemolítico en Argentina. Medicina (Buenos Aires). 2004, 64: 352-356.

***Dra. Gabriela Arakelian** Revisora
Pediatria. Nefróloga infantil

SÍNDROME NEFRÍTICO

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría



Dr. Jorge Larcamón

Jefe de Servicio

Dr. Claudio Ambrosis

Jefe de Consultorios Externos

Dra. Paola Basualdo

Instructora de Residentes

Dra. María José Loos

Pediatra, Especialista en Nutrición

Dra. Aldana Briceño

Pediatra

Dra. Sandra Miranda

Dra. Sofía Jiménez

Residentes

Dra. Gabriela Arakelian*

Revisora

Sumario

El Síndrome nefrítico es un desafío para el pediatra porque a pesar que la Glomerulonefritis post-estreptocócica es de las etiologías más frecuentes, en otras ocasiones es el debut de enfermedades sistémicas o renales menos frecuentes. Así el pediatra deberá tratar los síntomas agudos del paciente, previniendo las complicaciones como el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la encefalopatía hipertensiva y la necesidad de diálisis.

Situación Clínica

Ciro, de 10 años de edad, concurre a la guardia por presentar en las últimas 48 horas micciones de orinas de coloración oscura.

Presenta antecedente de odinofagia asociado a fiebre de 38.5° C durante la semana previa.

Es un niño previamente sano, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. No

refiere antecedentes de traumatismos, no presenta lesiones de infección en piel ni rash exantemático.

Examen físico al ingreso:

Paciente en buen estado general, afebril.

Signos vitales: FC: 110 lpm, Fr: 30 rpm, TA: 140-90 mmHg.

Peso y talla en PC: 50.

Presenta edema en párpados y pretibiales que dejan fóvea. Pulsos positivos y simétricos, relleno capilar 2 segundos.

Hipertenso, TA en PC > 95.

Resto de examen físico normal.

Exámenes complementarios:

Se solicita al paciente recolección de orina donde se constata hematuria mediante tira reactiva de orina.

GB: 16.320 /mm³ (67% Neutrófilos) Hb: 10, 2 gr/dl, Hto: 30%

Urea: 52 mg/dl, Creatinina: 1,8 mg/dl
Ionograma: Na: 139/ K+:4,6/ Cl:110 mEq/l
Albumina: 3.7 gr/dl, Glicemia: 93 mg/dl

Reflexiones

En este caso clínico, el paciente cursa cuadro caracterizado por edema facial y en extremidades inferiores, hematuria macroscópica, proteinuria e hipertensión arterial característicos del síndrome Nefrítico.

Como antecedente de importancia destaca la presencia de cuadro febril asociado a odinofagia la semana previa lo cual nos hace pensar en etiología posinfecciosa.

El caso clínico descrito hace referencia a las principales características del síndrome nefrítico, el objetivo del capítulo es hacer una reseña de cuándo y cómo encararlo.

DEFINICIÓN:

El Síndrome Nefrítico (SN) es un cuadro clínico agudo que se da como consecuencia de un proceso inflamatorio glomerular el cual ocasiona retención de agua, sodio y por lo tanto hipervolemia.

Está caracterizado por la instauración repentina de:

- ✓ Hematuria
- ✓ Hipertensión arterial
- ✓ Oliguria
- ✓ Edema

El cuadro de insuficiencia renal en general se acompaña de proteinuria leve/moderada. Muy rara vez cursa con proteinuria en rango nefrótico.

ETIOLOGÍA:

En nuestro país la glomerulonefritis estreptocócica es la causa más frecuente, y se da en más del 90 % de los casos. Existen más de 80 tipos de estreptococos pero no todas las cepas tienen características nefritógenas. Afecta principalmente niños entre los 2 y los 15 años.

De acuerdo a su patogenia podemos clasificarla como secundaria a mecanismos inmunológicos (depósito de Ag-Ac) o no inmunológicos (ej microangiopatía trombótica del SHU, Schonlein Henoch, progresión del daño renal de la insuficiencia renal crónica, etc).

La clasificación de mayor utilidad para guiarnos a la etiología es si presenta hipocomple-

mentemia o normocomplementemia.

1. Síndrome Nefrítico con complemento C3 bajo:

De origen renal:

Glomerulonefritis intra o postinfecciosa:

-Bacteriana: Estreptococo B hemolítico grupo A, Neumococo, Meningococo, Haemophilus influenzae, Enterococo, Salmonella typhi, Treponema pallidum, etc.

-Viral: Coxsackie, Sarampión, Varicela, Enterovirus, Parotiditis, Hepatitis B, Citomegalovirus, Rickettsia.

-Parásitos: toxoplasmosis, paludismo.

Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I y II B.

De origen sistémico:

Lupus eritematoso sistémico.

Crioglobulinemia

Endocarditis bacteriana.

Nefritis del Shunt.

2. Síndrome Nefrítico con complemento C3 normal:

De origen renal:

Nefropatía por Ig A (enf de Berger)

GN rápidamente progresiva idiopática

Enfermedad por Ac antimembrana basal glomerular

Nefritis familiar

De origen sistémico:

Púrpura de Schoenlein Henoch

Síndrome Urémico Hemolítico

Síndrome de Goodpasture

Vasculitis: PAN, Granulomatosis de Wegener, Poliangeitis microscópica

Absceso cerebral

FISIOPATOLOGÍA:

El mecanismo patogénico está dado por la lesión inflamatoria glomerular producida por:

- ✓ Formación del complejo inmune circulante: Se producen en el torrente sanguíneo por un antígeno nefritogénico estreptocócico y su anticuerpo.
- ✓ Formación in situ de complejos inmunes: con una activación secundaria del complemento produciendo daño glomerular por activación de la vía clásica del sistema del complemento.

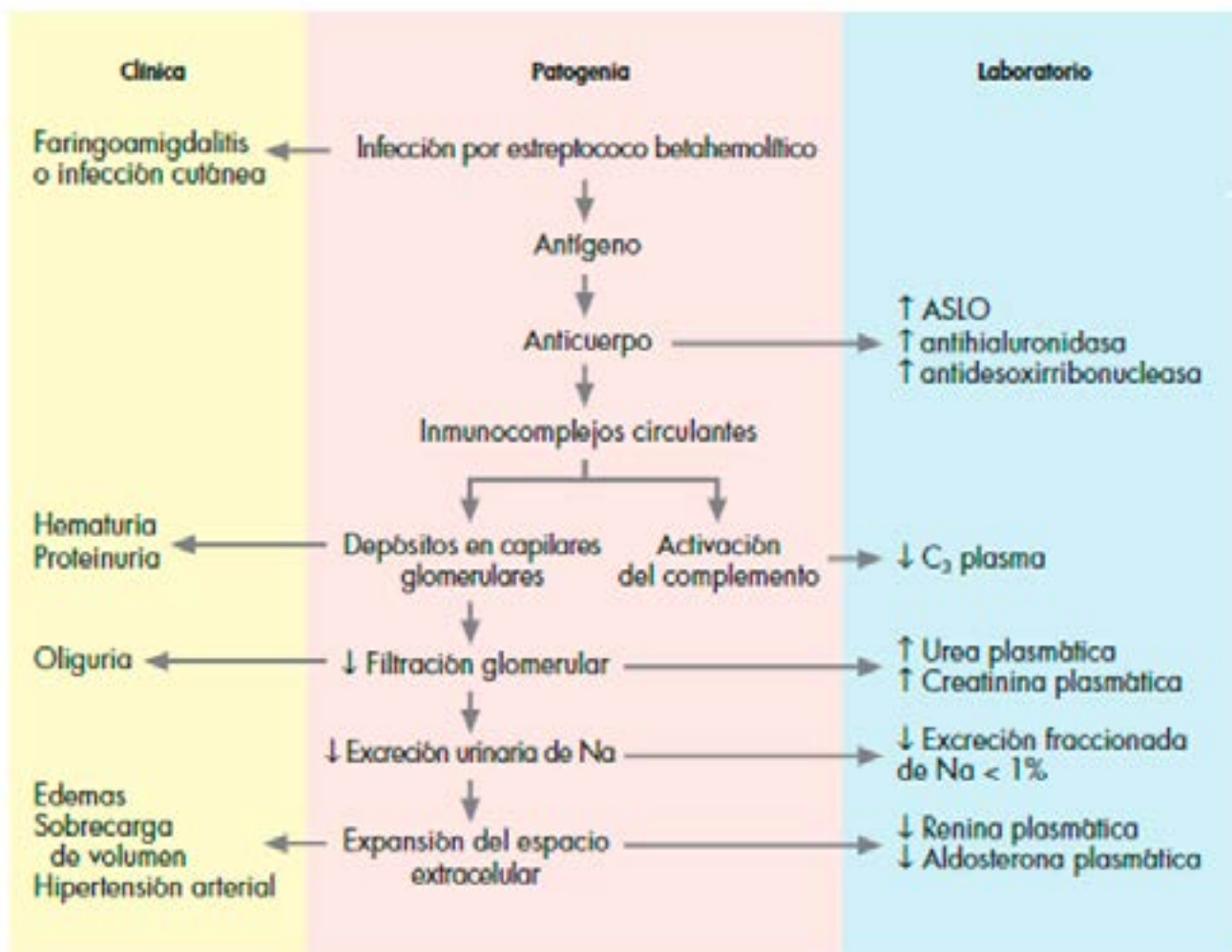
- ✓ Células infiltrantes: granulocitos, monocitos y macrófagos como un posible elemento de daño glomerular directo debido a las citocinas quimiotácticas y proinflamatorias, desencadenadas por la activación del complemento
- ✓ Antígenos de streptococcus nefritogénicos: el gliceraldehído-3-fosfato bacteriano receptor de plasmina (NAPlr) y la cisteína proteinasa catiónica estreptocócica exotoxina B de pirógenos (SPEB). Ambas proteínas activan la vía alternativa de la cascada del complemento
- ✓ Hipótesis patogenética de glomerulonefritis postestreptococcica: la nefritis puede ser inducida por un superantígeno (toxina del síndrome de choque tóxico por exotoxina, TSST-1) que estimula la actividad alta de citocinas, producción de IgA, formación de IgA y deposición del complejo inmune.
- ✓ Anticuerpos contra los componentes de la estructura del glomérulo (p.ej., en la en-

fermedad de Wegener contra la membrana basal)

- ✓ Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) que facilitan el diagnóstico y la clasificación de determinadas vasculitis sistémicas y las GN necrosantes

Estos depósitos de Ag-AC producen una cascada de mediadores inflamatorios que son los responsables del incremento de la permeabilidad a las proteínas y la disminución del filtrado glomerular, y eso provoca las alteraciones estructurales del glomérulo, con hiper celularidad, trombosis, necrosis y formación de semilunas.

Se produce un aumento de la reabsorción de Na^+ en la nefrona distal, especialmente en el túbulo cortical y eso conlleva una retención de líquidos y sal, con un sistema renina-angiotensina-aldosterona que funciona normalmente (fig. 1). Esto se traduce en expansión de volumen extracelular y el consecuente edema, sobrecarga cardiocirculatoria e hipertensión arterial.



Fuente: Mur O. de la Mata. síndrome Nefrítico . Anales de pediatría.

CLÍNICA:

Puede adoptar diversas formas clínicas y hay un amplio espectro de severidad.

Según el grado de afectación renal los pacientes pueden desarrollar grados variables de oliguria, HTA y edemas.

La presentación puede variar de casos subclínicos con microhematuria y función renal normal a casos con insuficiencia renal aguda con edema generalizado, insuficiencia cardíaca y/ o encefalopatía hipertensiva.

Los motivos de consulta más frecuentes son las orinas oscuras y los edemas.

En la forma más frecuente la hematuria, los edemas leves, la oliguria y la hipertensión ceden paulatinamente en 3-15 días.

En la mayoría de los pacientes surge en el interrogatorio el antecedente de infección estreptocócica las semanas previas con un periodo de latencia de 3 a 6 semanas para la piodermitis y 3 a 4 semanas para la faringitis.

Durante el período agudo la hematuria está presente en el 100% de los pacientes, con un 50 % de macrohematuria.

Los edemas están presentes en el 75 % de los pacientes y se presentan en forma generalizada sin ascitis.

La hipertensión es secundaria a sobrecarga de volumen por retención hidrosalina y se presenta en el 70 % de los casos como HTA moderada en la fase oligúrica.

Como consecuencia de esta puede haber dos complicaciones graves: el edema agudo de pulmón y la encefalopatía hipertensiva.

Es frecuente también la aparición de síntomas inespecíficos como malestar general, aletargamiento, dolor abdominal o en fosa lumbar y fiebre.

Por lo general la fase aguda: proteinuria e HTA se resuelve en 6-8 semanas aunque la microhematuria puede persistir de 1-2 años.

EXAMEN FÍSICO:

Teniendo en cuenta que el cuadro clínico estado como consecuencia de la sobrecarga de volumen tendremos que realizar:

Peso y talla: Para evaluar signos de sobrecarga de volumen.

Signos vitales: FC, FR, Temperatura.

TA (se realiza percentilo de acuerdo al percentilo de talla del paciente).

Balance estricto de ingresos y egresos.

Inspeccionar la presencia de edemas (palpebrales, pretibiales, sacros).

Buscar la presencia de infección respiratoria alta, faringoamigdalitis, infecciones en piel u otras.

Búsqueda de adenopatías, visceromegalias.

Detectar signos de insuficiencia cardíaca: taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia, ingurgitación yugular, disnea, rales subcrepitanes, posición de ortopnea.

Síntomas Neurológicos: cefalea, alteraciones del sensorio, signos de foco, edema de papila, trastornos visuales, convulsiones (signos de encefalopatía hipertensiva). Se debe realizar, fondo de ojo en todo paciente con trastornos del sensorio, fotofobia, vómitos.

DIAGNÓSTICO:

Exámenes de orina:

En el examen de orina se evaluará presencia de sangre por tira de orina o por visión directa. Es importante diferenciar hematuria de origen glomerular de urológica. La hematuria glomerular se describe como marrón, té o coca cola.

En el examen microscópico pueden aparecer glóbulos rojos dismórficos los cuales son característicos del sangrado glomerular, cilindros hemáticos, granulados y hialinos.

También se evaluará la presencia de proteinuria de 24 hs (por debajo de 40 mg/m²/h o 50 mg/k/día) y en los niños más pequeños índice proteinuria/ creatininuria de una micción.

Otros exámenes complementarios que deben solicitarse:

Hemograma: Anemia dilucional aumento de VSG.

Urea y Creatinina: se encuentran elevados indicando grado de insuficiencia renal.

Ionograma: Hiponatremia hipervolémica.

El Potasio se encuentra normal ó aumentado debido a un hipoaldosteronismo hiporrenínico transitorio.

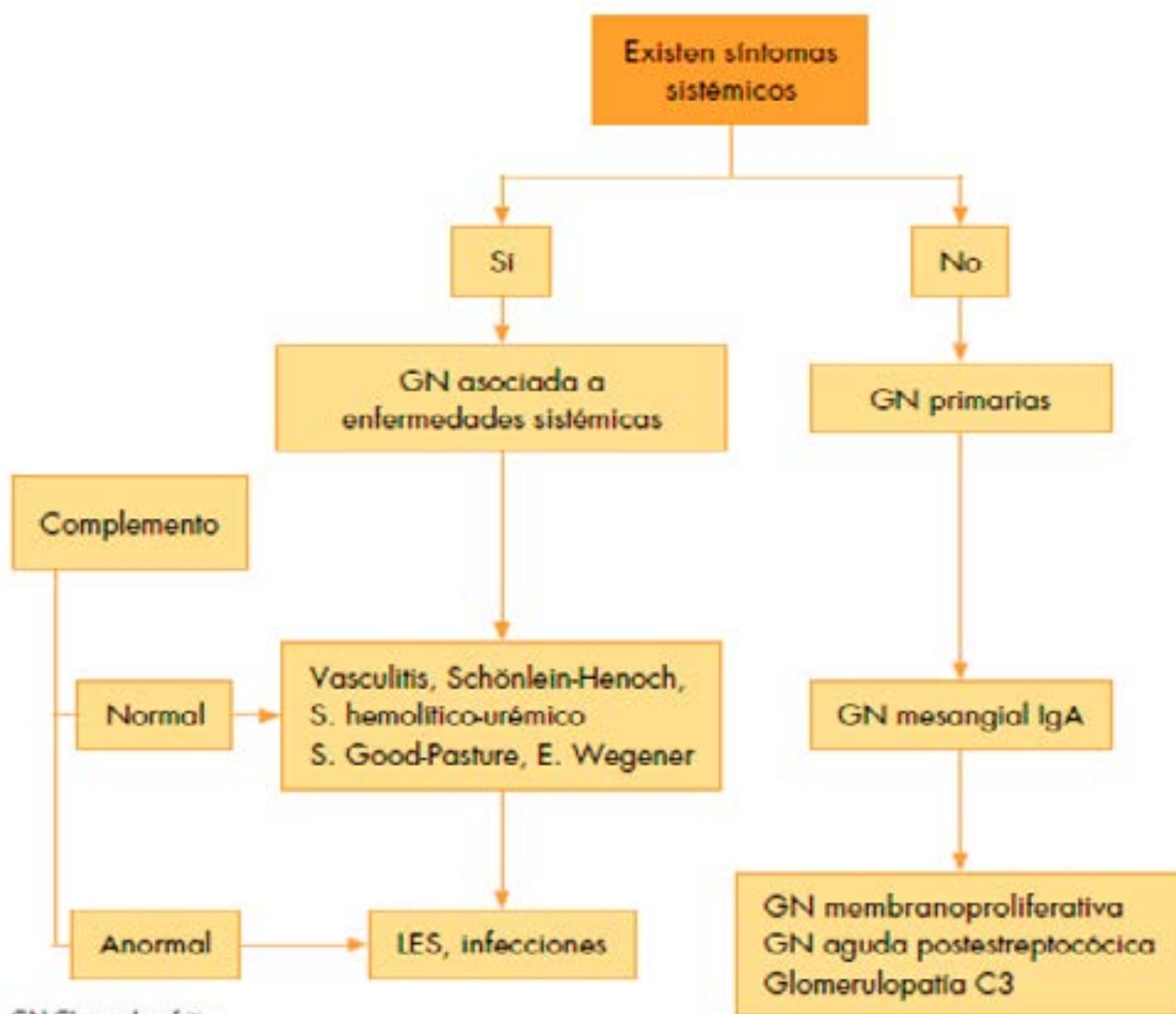
Rx Tórax: Se buscan signos de Hipervolemia: aumento del índice cardiotorácico (>0,5), infiltrados alodonomos bibasales en edema agudo de pulmón.

Acidosis según el grado de insuficiencia renal.

Excreción fraccionada de sodio (EFNa⁺ < 1%)

Disminución de C3 (VN 80-160mg/dl), C4 Normal (VN 20-40mg/dl).

Los niveles de C3 disminuyen en más del 90% de todos los casos de glomerulonefritis aguda postestreptocócica y los niveles vuelven a la



Enfoque diagnóstico del síndrome nefrítico.

normalidad en un máximo de 8 semanas
 Cultivo de Fauces o de piel: su negatividad no descarta la etiología estreptocócica
 ASTO: puede estar normal o aumentado.
 Urocultivo: para descartar infección urinaria.
 FAN y anti ADN: indicadores importantes en Nefropatía Lúpica.
 Anticuerpos: los AC- Antistreptolisina (ASO) se elevan en un 80-90% en la faringitis estreptocócica, empieza a aumentar entre las semanas 1 a 4 después de la infección y alcanza su punto máximo entre las 3 y 5 semanas. En los casos de piodermitis estreptocócica las antiestreptolisinas suelen estar bajas; mientras que los anticuerpos anti ADNasa B aumentan en un 80- 90%.

Serologías de hepatitis virales B y C, sífilis y VIH.
 Ecografía renal y de vías urinarias
 Fondo de ojos debe realizarse en todo paciente con clínica de encefalopatía hipertensiva.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN

Todos los pacientes con Síndrome nefrítico tienen criterio de internación para evaluar el grado de retención hidrosalina.

TRATAMIENTO

Todas las medidas terapéuticas estarán orientadas a disminuir la hipervolemia y sus complicaciones.

Hipervolemia

- Restricción hidrosalina: se limita la ingesta de líquidos a 300-400 ml/m² /día (pérdidas insensibles) más la mitad de la diuresis.

- Dieta hiposódica 1-2 meq/k/día) hasta 3 meses posterior al alta.

- Diuréticos: se administra furosemida 1-2 mg/kg/dosis EV cada 6 horas en pacientes con hiperflujo pulmonar y/o cardiomegalia con o sin insuficiencia cardíaca. De no existir respuesta diurética positiva (mayor a 10 ml/k/día en 4 hs) durante la primera hora, se aumentará la dosis de furosemida cada hora pudiéndose aumentar hasta 8 mg/kg/dosis.

El 90 % de los casos responde luego de la primera dosis de furosemida logrando un balance negativo de líquidos.

Cuando desaparecen los signos de hiperflujo pulmonar se continúa con furosemida a 2 mg/kg/día vo hasta llegar al peso seco del paciente.

La hipertensión arterial:

Responde a la restricción hidrosalina y los diuréticos, dado que es volumen dependiente. Si la hipertensión no resuelve se utiliza un vasodilatador, el más utilizado es el bloqueante cálcico: Nifedipina 0.2-0.5 mg/kg/dosis, VO (dosis máxima 1 mg/kg/día.)

En caso de encefalopatía hipertensiva

Es necesario utilizar Nitroprusiato de sodio a 0.5 mcg/kg/minuto, hasta un máximo de 8 mcg/kg/minuto en infusión continua por vía central, con monitoreo continuo, en Unidad de Cuidados Intensivos, de la tensión arterial media (TAM), cuyo descenso no debe ser mayor al 25% durante las primeras horas.

Hiperkalemia:

Suele responder a los diuréticos, pueden utilizarse resinas de intercambio, si no resuelve con estas medidas requiere diálisis.

Antibiótico beta lactámico: La penicilina continúa siendo el tratamiento de primera elección en la faringoamigdalitis estreptocócica por su sensibilidad y bajo costo estará indicada en los pacientes que cursan una infección aguda.

SEGUIMIENTO:

En el primer mes se deben realizar control semanal. Solicitar función renal, orina completa y

determinación de la presión arterial.

En el primer trimestre, el control es mensual, se debe solicitar función renal, presión arterial, orina completa se agrega complementemia, y ecografía renal.

Lo que resta del primer año, el control es trimestral y continúa con control de función renal, orina completa, presión arterial y complementemia.

La función renal se recupera entre la primera y segunda semana de inicio del cuadro.

Los niveles de complemento se normalizan en las primeras 8 semanas.

La dieta hiposódica debe mantenerse durante tres meses.

La hematuria microscópica puede persistir durante uno o dos años

La proteinuria desaparece en un período de 3-6 meses.

INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL:

Los pacientes con hematuria de características glomerulares con presión arterial, función renal normal y proteinuria baja no requieren biopsia renal. La biopsia renal está indicada en los siguientes casos:

- ✓ Edad de presentación atípica: < 2 años y >12 años.
- ✓ Síndrome nefrótico asociado a signos de enfermedad sistémica.
- ✓ Hipocomplementemia persistente, después de la octava semana.
- ✓ Síndrome nefrítico con disminución la función renal que no resuelve en el periodo agudo.
- ✓ Proteinuria persistente.
- ✓ Hematuria persistente (microscópica más de 1 años y macroscópica más de 4 semanas)
- ✓ Hipertensión Arterial persistente.
- ✓ Todo síndrome nefrítico con evolución rápidamente progresiva, con aumento de 0.5 mg/ dl de la creatinina por día o disminución del filtrado glomerular.

COMENTARIO DEL ESPECIALISTA

El Síndrome nefrítico es un desafío para el pediatra porque a pesar que la GN post-estreptocócica es una de las etiologías más frecuentes, en otras ocasiones es el debut de enfermedades sistémicas o renales menos frecuentes.

Así el pediatra deberá tratar los síntomas agudos del paciente, previniendo las complicaciones como el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la encefalopatía hipertensiva y la necesidad de diálisis.

Por otro lado deberá evaluar los factores de riesgo como la HTA refractaria al tratamiento, la persistencia de proteinuria en rango nefrótico o de C3 disminuido, la evolución hacia una GN rápidamente evolutiva que le permitirá la consulta oportuna al especialista quien decidirá el momento óptimo para realizar biopsia renal, para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de base.

Bibliografía

- Avendaño, L. H. (2009). *Nefrología clínica*. Ed. Médica Panamericana.
Comité de nefrología. Sociedad Argentina de Pediatría filial Salta.
SÍNDROME NEFRÍTICO.
Evidencias y Recomendaciones Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: GPC-IMSS-826-18. Diagnóstico y Tratamiento del SÍNDROME NEFRÍTICO AGUDO POSTESTREPTOCÓCICO EN EDAD PEDIÁTRICA.
Hernández, M. E. (2014). Síndrome nefrítico. *Anales de Pediatría Continuada*, 12(1), 1-9.
Mur, O, De la Mata, G. (2004). Síndrome nefrítico. *Anales de Pediatría Continuada*, 2(4), 216-222. Comité de Nefrología.

***Dra. Gabriela Arakelian** Revisora
Nefróloga Infantil

SÍNDROME NEFRÓTICO

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría



Dr. Jorge Larcamon

Jefe de Servicio

Dra. Adelma Herrera

Jefa de Sala

Dra. Paola Basualdo

Instructora de Residentes

Dra. Mónica García

Dra. Cecilia Gorriti

Dra. Giselle Pérez

Pediatras

Dra. Mariela A. Vilar Pereira

Residente

Dr. Roberth Wagner Pazmiño

Concurrente

Dra. Mariela Ríos *

Revisora

Dr. Ezequiel Varela**

Revisor

Sumario

El diagnóstico de Síndrome Nefrótico Primario es el más prevalente, de los cuales el 90% se muestra sensible frente al tratamiento inicial con corticoides, si bien son frecuentes las recaídas, el trabajo en conjunto entre el clínico pediatra y el nefrólogo pediatra es fundamental para evitar la causa más frecuente de falla terapéutica: el cumplimiento errático del tratamiento por parte de los padres. Es por esto que el acompañamiento integral del paciente y de su familia, con controles periódicos y estando muy atentos a las posibles complicaciones, generan las condiciones necesarias para el control de la patología.

Situación clínica

La madre trae a la consulta a Joaquín, de 4 años

de edad, por notarle los ojos “hinchados” desde hace unos días.

Anamnesis: Refiere que comenzó hace aproximadamente 5 días, incrementándose esta mañana. No refiere edemas en otras partes del cuerpo. Presenta catarro de vías aéreas superiores hace una semana, sin fiebre. No refiere otros síntomas, ni episodios previos similares.

Consultó en un centro de salud donde le indicaron un antihistamínico, sin mejoría clínica.

Examen físico

Signos vitales FC 80 x min., FR 20 x min., TA 100/60 mmHg (<Pc90 para la edad), SatO₂ 100%.

Edema de párpados, edema pre tibial que deja godet +++, percusión de abdomen con matidez en flancos e hipogastrio que se desplaza al po-

nerlo en decúbito lateral. Sin edema escrotal.

Examen neurológico normal. Auscultación cardíaca sin particularidades, bien perfundido.

Reflexiones

¿Qué diagnóstico pensaría inicialmente?

Frente a un paciente con edemas, el razonamiento debe llevarnos a distinguir entre el edema localizado (por inflamación o mecánico) y el edema generalizado producido por un aumento del agua y sodio corporal total a expensas del líquido extracelular (LEC).

Razonamiento fisiopatológico frente al edema generalizado

El aumento del agua corporal total a expensas del LEC nos lleva a deducir un balance positivo con ganancia de sodio (Na), al descartar como causa el exceso de aporte (el niño no se encontraba internado ni recibió aporte externo alguno), nos queda la excreción insuficiente como mecanismo probable.

Es aquí donde deberemos profundizar en la anamnesis y el examen físico, y solicitar exámenes complementarios que nos ayuden a discriminar entre la falta de filtrado (SUH, GN oligoanúrica), el disbalance glomérulo-tubular (síndrome nefrótico) o al aumento de la reabsorción como causante del cuadro.

Exámenes complementarios

Sangre: leucocitos normales, sin anemia ni plaquetopenia, función renal (urea, creatinina, EAB, ionograma) normal, hepatograma normal, albúmina 1.9 g/dL, colesterol total 265 mg/dL.

Sedimento urinario: leucocitos 1-3 por campo, hematíes 0-2 por campo, piocitos no se observan.

Tira reactiva: hemoglobina negativa, proteinuria +++++.

Se realiza radiografía de tórax donde no se evidencian signos de hipervolemia.

Conceptos fundamentales

Volumen Arterial Efectivo VAE: componente del volumen sanguíneo (15%) al que el sistema regulador responde estimulando la reabsorción de sodio y agua (activación del RAAS y HAD), aún cuando el volumen de sangre total pueda estar aumentado (disminución del gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca congestiva o

contracción del volumen intravascular por disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia).

Hipoalbuminemia:

Falta de ingreso: desnutrición proteica (kwashiorkor)

Falta de digestión: insuficiencia pancreática (fibroquística)

Falta de absorción: síndrome de mal absorción

Falta de producción: insuficiencia hepática (hepatopatías)

Pérdidas aumentadas:

renal (síndrome nefrótico)

intestinal (enteropatías inflamatorias)

Recapitulando

Joaquín no presenta antecedentes personales de relevancia previos a la consulta. Su curva de crecimiento se encuentra dentro de parámetros normales al igual que su peso y talla actuales. Catarsis y diuresis conservadas, sin cambios de coloración. Refiere menor diuresis y espumosa.

¿Qué conducta tomaría frente a este paciente en el cual sospechamos un síndrome nefrótico?

La internación solamente es necesaria en caso de riesgo de descompensación hemodinámica por hipovolemia con hipo perfusión renal y necrosis tubular aguda (diarrea, vómitos, anasarca, causa social).

Solicitamos entonces los siguientes análisis complementarios:

ASTO, C3-C4, serologías: VDRL-VIH-HepB-HepC-CMV-EBV, para descartar causas secundarias.

Ecografía renal con doppler y vesical, para descartar trombosis de la vena renal.

Prueba cutánea de PPD, previo al inicio del tratamiento.

Índice proteína/creatinina para cuantificar la pérdida y confirmar el diagnóstico.

Luego de hablar con la madre acerca de nuestra sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta que ella podrá cumplir con los controles y seguimiento, se decidió indicarle una dieta hiposódica, normo proteica e ingesta de líquidos (no azucarados) según sed, y se lo cita a consultorio para evaluación de resultados e inicio del tratamiento.

Síndrome Nefrótico

Definición: Edema, hipoalbuminemia ($\leq$ a 2,5 g/dL) y proteinuria en rango nefrótico.

Pérdida de proteínas en orina mayor o igual ($\geq$) a 50 mg/kg/día o 40 mg/m²/hora o índice proteinuria/creatininuria (PrU/CrU) en muestra aislada $\geq$ a 2 (expresado en mg/mg).

La proteinuria es el signo clínico de la lesión del podocito (podocitopatía) que causa pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través de la pared capilar glomerular.

Clasificación y etiología

El síndrome nefrótico puede ser: a) primario (SNP) o b) secundario.

SN primario: su etiología es desconocida, se postula la pérdida de la selectividad de la filtración para la carga y la forma de las sustancias que atraviesan la superficie de filtración glomerular. En algunos casos, sobre todo con presentación precoz, grave y con corticorresistencia, es posible identificar mutaciones en ciertos genes, lo que define al SN genético. Aquel asociado a anomalías del fenotipo y en menores de 1 año se define como SN congénito.

SN secundario: a glomerulonefritis, enfermedades sistémicas, hereditarias, víricas, parasitarias, neoplasias o fármacos.

El SN idiopático constituye el 90% de los SN en niños entre 2 y 12 años, es el más frecuente en la infancia. De ellos, alrededor del 90% responderá a la terapia inicial con corticoides, basándonos en estudios que asocian al SNP con una histología renal por biopsia de “cambios mínimos”, el 10% restante que no responde deberá investigarse a través de la realización de una biopsia renal.

La incidencia en población pediátrica menor de 14 años es 1.7 a 1.9 nuevos casos por 100.000 niños por año.

Se presenta preferentemente entre 2-8 años con máxima incidencia 3-5 años. En niños es dos veces más frecuente en varones, diferencia que no existe en adolescentes y adultos.

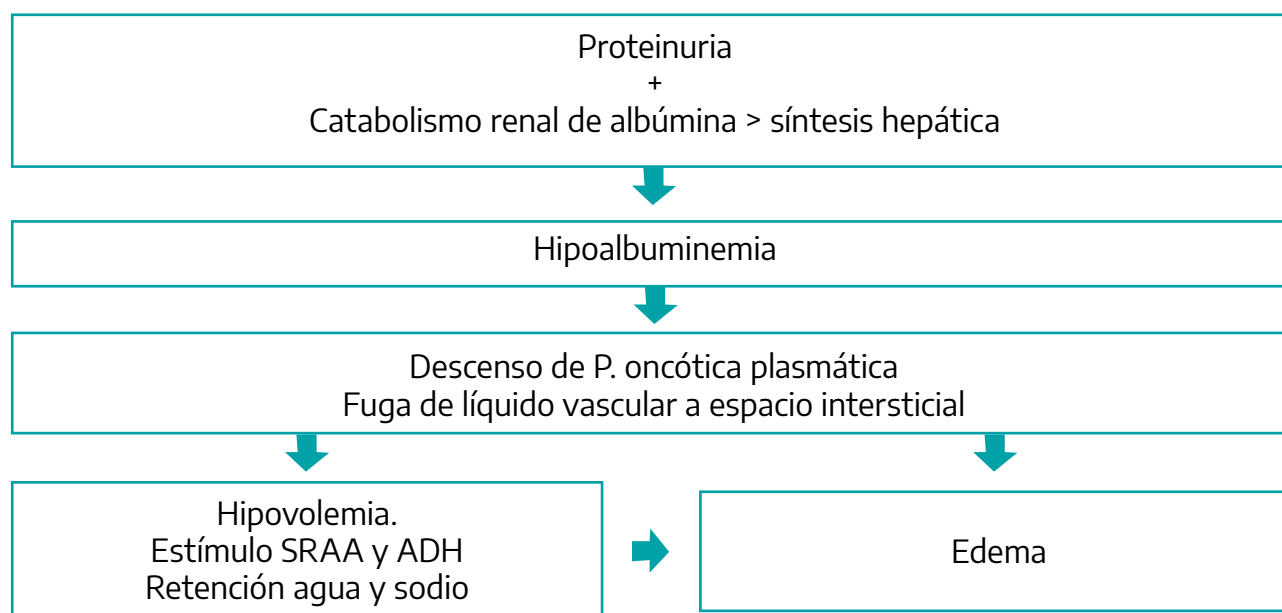
Fisiopatología del edema

La retención de sodio y el edema tradicionalmente se ha considerado secundario a la hipovolemia y activación del sistema renina-angiotensina - aldosterona (SRAA) (“Teoría Underfill”).

A partir de la proteinuria y la consecuente hipoalbuminemia, lo cual lleva al descenso de la presión oncótica y a la extravasación del líquido vascular al espacio intersticial con la generación de edema. La contracción del volumen arterial efectivo activa el sistema RAA y la secreción de hormona antidiurética lo que lleva a una mayor retención de sodio y agua, y aumento del edema.

Sin embargo, el mecanismo antes descripto

FORMACIÓN DEL EDEMA - TEORÍA UNDERFILL



no explica el edema en pacientes con niveles de albúmina no tan bajos, y tampoco explica la desaparición del edema luego del tratamiento en pacientes que aún no recuperan niveles normales de albúmina. Por lo que se vio que en la mayoría de los pacientes el mecanismo fundamental es la alteración del balance tubular renal ("Teoría Overflow") que condiciona la retención del sodio, la expansión del volumen plasmático y la transudación de agua y solutos al intersticio. Esto se debería a la activación de canales epiteliales de sodio (ENAC) a nivel del túbulo contorneado distal, debido a la presencia de plasmina en la orina de los pacientes en recaída de síndrome nefrótico.

Tratamiento

Objetivos

Lograr la inducción de la remisión para obtener una mejoría sintomática, es decir: proteinuria en rango fisiológico, recuperación de la diuresis, desaparición de los edemas y normalización de la albuminemia y, en segundo lugar, minimizar los efectos adversos secundarios a los inmunosupresores.

Corticoides

La principal acción de los glucocorticoides es el efecto antiinflamatorio e inmunosupresor sobre linfocitos T. Ejercen una acción directa sobre las células glomerulares e inmunes: podocitos, células endoteliales, linfocitos T, macrófagos y células dendríticas; inhiben la apoptosis y favorecen su estabilización funcional.

Tratamiento inicial

Indicaciones generales

- Dieta hiposódica.
- Líquidos medidos para lograr un balance negativo de agua.
- En pacientes con anasarca y con signos clínicos de hipovolemia, infundir albúmina 0,5-1g/kg EV en 2 horas, asociada a furosemida 1mg/ kg/dosis en la mitad y al final de la infusión.
- Prednisona 2 mg/kg o 60 mg/m² en días continuos (dosis máxima, 60 mg/d) durante 4-6 semanas, en 1 toma, dosis diaria a la mañana entre las 8 y las 10 h, seguido de prednisona 1,5 mg/kg o 40 mg/m² en días alternos durante 4-6 semanas.

Equivalencia: prednisona 1mg = meprednisona 0,8 mg.

En nuestro país es más accesible la meprednisona.

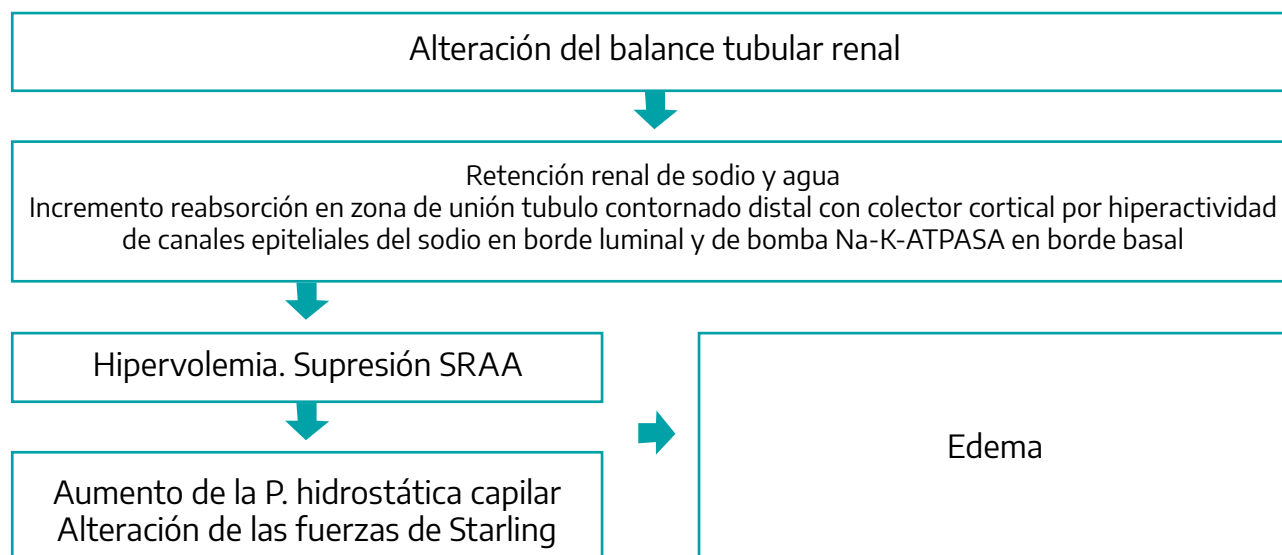
La mayoría de los pacientes cortico sensibles remiten la proteinuria entre los 5 y los 7 días del comienzo del tratamiento; son muy pocos los que lo hacen en forma tardía.

La respuesta es clínicamente visible por el aumento significativo de la diuresis, la desaparición de los edemas y la normalización de los parámetros de laboratorio.

• Remisión

Descenso de la proteinuria a valores fisiológicos (< a 5 mg/kg/d o < 4mg/m²/h o un índice PrU/CrU < 0,20) o una tirilla reactiva en orina negativa, durante 3 días consecutivos.

FORMACIÓN DEL EDEMA - TEORÍA *OVERFLOW*



El 80% de los pacientes presenta remisión luego de un tratamiento inicial con corticoides.

- *Recaída*

Reaparición de la proteinuria en rango nefrótico o tira reactiva en orina con 2 o más cruces durante 5 días consecutivos o reaparición de edema, sin proceso infeccioso concomitante.

Más del 80% de los pacientes presentan recaídas en la evolución de la enfermedad.

- *Recaídas frecuentes*

Más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en 1 año.

- *Cortico dependencia*

Dos recaídas consecutivas al descender los corticoides o dentro de las 2 semanas siguientes a la suspensión de estos. Ambos grupos de pacientes responden al tratamiento con corticoides y en la práctica clínica no se diferencian en las alternativas de tratamiento propuestas por el consenso.

- Corticorresistencia: es la falta de remisión de la proteinuria luego de un tratamiento con:

Opción a) prednisona 2 mg/kg/d o 60 mg/m²/d (dosis máxima, 60 mg) en días continuos durante 4-6 semanas en 1 dosis diaria a la mañana entre las 8 y las 10 h, seguido de prednisona 1,5 mg/kg o 40 mg/m² en días alternos durante 4-6 semanas.

Opción b) prednisona 60 mg/m²/d o 2 mg/kg/d durante 4-6 semanas en días continuos más 3 pulsos de metilprednisolona de 10 mg/kg/dosis.

El manejo clínico de estos niños es muy difícil dado que presentan, durante la evolución, complicaciones relacionadas con la proteinuria masiva, el estado nefrótico crónico y el tratamiento inmunosupresor:

- *Detención del crecimiento*
- *Desnutrición*
- *Edema crónico refractario al tratamiento*
- *Infecciones*
- *Hiperlipidemia*
- *Anemia*
- *Hipertensión arterial*
- *Insuficiencia renal.*

Tratamiento complementario

- *Calcio: 500-1000 mg/d.*

- *Vitamina D: 1000 UI/d.*

- *Protector gástrico.*

Comentario

El síndrome nefrótico es una patología con una gran variedad de etiologías y patrones histológicos que muestran la amplia gama de opciones terapéuticas, el desafío actual es lograr reducir al mínimo la toxicidad y prevenir las complicaciones más comunes (infecciones, necrosis tubular aguda y trombosis).

El diagnóstico temprano y el inicio de la terapia adecuada es fundamental para el pronóstico y evolución del paciente como rol del pediatra en su atención inicial.

ALGORITMO RESUMIDO DE CONDUCTA ANTE LA CONSULTA DEL NIÑO CON EDEMAS

1º. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME EDEMATOSO SISTÉMICO.

2º. DIAGNÓSTICO DE MECANISMO (disminución volumen arterial efectivo por disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia < 3g/dL).

3º. PÉRDIDA RENAL (proteinuria en rango nefrótico ≥ 50mg/Kg/d o Pr/Cr ≥ 2mg/mg).

4º. SÍNDROME NEFRÓTICO PRIMARIO (ausencia de sedimento nefrítico, de hipertensión arterial, de caída de filtrado glomerular y de hipo complementemia).

5º. TRATAMIENTO DE PRUEBA CON GLUCOCORTICOIDES: prednisona 60mg/m²/d ó 2mg/Kg/d (consulta inicial con pediatra nefrólogo).

6º. SI ES CÓRTICO – SENSIBLE COMPLETAR TRATAMIENTO (no menos de 12 semanas) Y COMBINAR EL SEGUIMIENTO CON LA MADRE Y CON EL PEDIATRA NEFRÓLOGO.

7º. SI TIENE RECAÍDAS FRECUENTES DERIVAR A PEDIATRA NEFRÓLOGO Y CONTROLAR TOXICIDAD CORTICOIDE: 1-crecimiento; 2-presión arterial; 3-examen oftalmológico.

8º. SI ES CÓRTICO – RESISTENTE (inicial o posterior) DERIVAR A PEDIATRA NEFRÓLOGO Y MANTENER CONTROL PEDIÁTRICO (especial preocupación por inmunizaciones, teniendo en cuenta estado de disminución de las defensas durante período de SN activo: neumococo y varicela).

Bibliografía

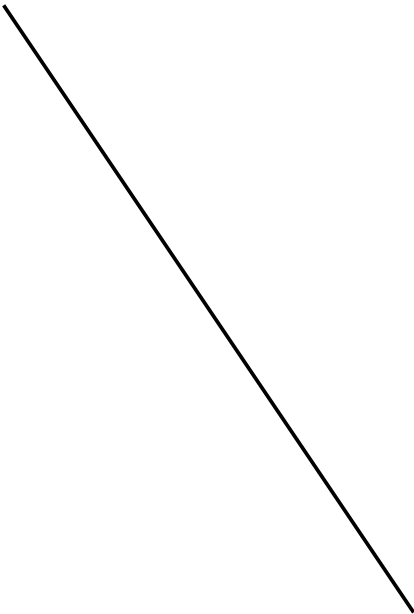
- Alconcher L, Meneguzzi B. Datos epidemiológicos del síndrome nefrótico en la Argentina. Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría. VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. 2008, 23-26 de noviembre, Buenos Aires.
- Arneil GC, Wilson EH. Cortisone treatment of Nephrosis. *Arch Dis Child* 1952;27(134):322-8.
- Barnett HL, Edelmann CM, Greifer I. The primary nephrotic syndrome in children. Identification of patients with minimal change nephrotic syndrome from initial response to prednisone. A report of the international study of kidney disease in children. *J Pediatr* 1981;98(4):561-4.
- Cattran DC, Alexopoulos E, Heering P, Hoyer PF, et al. Cyclosporin in idiopathic glomerular disease associated with the nephrotic syndrome: workshop recommendations. *Kidney Int* 2007;72:1429-47.
- Doucet A, Favre G, Deschênes. Molecular mechanism of edema formation in nephritic syndrome: therapeutic implications. *Pediatr Nephrol* 2007;22:1983-90.
- Gipson DS, Massengill SF, Yao L, Nagaraj S, et al. Management of Childhood Onset Nephrotic Syndrome. *Pediatrics* 2009;124:747-57.
- Hamahira K, Iijima K, Tanaka R, Nakamura H, Yoshikawa N. Recovery from cyclosporine-associated arteriolopathy in childhood nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol* 2001;16(9):723-7.
- Hamasaki Y, Yoshikawa N, Hattori S, Sasaki S, et al. Cyclosporine and steroid therapy in children with steroidresistant nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol* 2009;24:2177-85.
- Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children (Review). *The Cochrane Library* 2010, Issue 4.
- Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Non-corticosteroid treatment for nephrotic syndrome in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;1:CD002290.
- Iijima K, Hamahira K, Tanaka R, Kobayashi A, et al. Risk factors for cyclosporine-induced tubulointerstitial lesions in children with minimal change nephrotic syndrome. *Kidney Int* 2002;61(5):1801-5.
- Ingulli E, Singh A, Baqi N, Ahmad H, et al. Aggressive, longterm cyclosporine therapy for steroid-resistant focal segmental glomerulosclerosis. *J Am Soc Nephrol* 1995;5:1820-5.
- Inoue Y, Iijima K, Nakamura H, Yoshikawa N. Two-year cyclosporin treatment in children with steroid-dependent nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol* 1999;13(1):33-8.
- Na KY, Han JS, Kim YS, Ahn C, et al. Does Albumin Preinfusion Potentiate Diuretic Action of Furosemide in Patients with Nephrotic Syndrome? *J Korean Med Sci* 2001;16:448-54.
- Nephrotic Syndrome: Prediction of histopathology from clinical and laboratory characteristics at time the diagnosis. A report of International Study of Kidney Disease in Children. *Kidney Int* 1978;(13):159-65.
- Niaudet P, Habib R, Tete MJ, Hinglais N, Broyer M. Cyclosporin in the treatment of idiopathic nephrotic syndrome in children. *Pediatr Nephrol* 1987;1(4):566-73.
- Plank C, Bensman A, Niaudet P. Non-immunologic mechanisms of calcineurin inhibitors explain its antiproteinuric effects in genetic glomerulopathies. *Pediatr Nephrol* 2010;25:1197-9.
- Van Husen M, Kemper MJ. New therapies in steroidsensitive and steroid-resistant idiopathic nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol* 2011;26:881-92.

***Dra. Mariela Ríos** *Revisora*

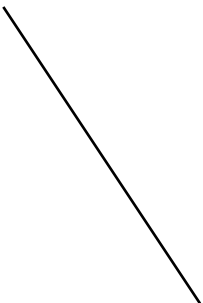
Nefróloga Infantil

****Dr. Ezequiel Varela** *Revisor*

Becario Nefrología Infantil del Hospital Nacional A. Posadas.



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **I**

RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA SEPSIS EN PEDIATRÍA

Hospital General Zonal de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela.
Residencia de Clínica Pediátrica.



Dra. Érica Moreno

Médica Asistente de sala de internación

Dra. Yanina Lagala

Dr. Cristian Olivera

Ex Residentes

Dra. Leticia Caballero

Dra. Lizet Fernández

Dra. Julieta Pardon

Residentes de 2º año

Dra. Mara Maydana *

Experta revisora

Sumario

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Si no se reconoce y trata de forma temprana, puede provocar rápidamente la muerte. La carga epidemiológica global de la sepsis es difícil de determinar. Se estima que afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo cada año, lo que puede provocar 6 millones de muertes, principalmente en países de bajos y medianos ingresos. La sepsis puede ser la manifestación clínica de infecciones adquiridas tanto en el entorno comunitario como en los centros de atención médica. Se ofrece una visión ampliada y la consiguiente recopilación bibliográfica.

Situación clínica

Paciente de 7 meses de edad, ingresa al Servicio de Guardia traído por sus padres por presentar CVAS, fiebre y poca actitud alimentaria de 4 días de evolución.

Antecedentes: RNT PAEG. Esquema de vacunación incompleto para la edad. Se registran 3 controles de salud. Madre adolescente, sin antecedentes familiares de importancia.

Examen físico al ingreso: Paciente en REG, febril, hemodinámicamente estable, palidez generalizada.

SV: T38.7°C FR64 FC170 SAT98% Máscara de reservorio TA 80/50 mmHg Peso 6,300 kg

Presenta REAB, se auscultan rales gruesos bibasales y subcrepitantes a predominio derecho,

tiraje sub e intercostal, se coloca máscara de reservorio.

Taquicárdico, no impresiona soplo, pulsos presentes, relleno capilar de 2 segundos.

Resto de examen físico sin particularidades.

Exámenes complementarios:

Analítica de rutina: GB 23000 (N54-L29) Hto 31% Hb9 Plaquetas 489000 Glucemia 98 Urea 22.

Radiografía de tórax: Se observa infiltrado radiopaco en base pulmonar derecha, senos costofrénicos libres.

Se interpreta cuadro clínico como Sepsis secundaria a foco respiratorio. Se realiza tratamiento de sostén, se toman muestras de Hemocultivos x 2 y Aspirado de secreciones nasofaríngeas (para aislamiento viral y PCR Bordetella Pertussis). Se indica Ceftriaxona 80 mg/kg EV, Claritromicina y Oseltamivir.

A las 6 hs de su ingreso, paciente persiste febril con empeoramiento clínico, por lo que se decide repetir radiografía de tórax donde se observa velamiento de hemitórax derecho con desplazamiento de mediastino al lado contralateral, compatible con derrame pleural. Se agrega a esquema antibiótico empírico Vancomicina 60 mg/kg/d EV. Se coloca tubo de avenamiento pleural, se obtiene material purulento tomando muestra para Citofisicoquímico y cultivo.

Al no presentar mejoría con tratamientos de sostén realizados, paciente con diagnóstico de Shock séptico y Neumonía complicada, se decide ingresar en Asistencia Ventilatoria Mecánica, y se deriva a UTIP.

*Resultados de cultivos: HMC x2 Y líquido pleural positivos para Staphylococcus Aureus Metilino Resistente.

Sepsis en Pediatría

Introducción

La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en los niños de todo el mundo y, por lo tanto, de alta prioridad para la salud pública.

Los datos mundiales son incompletos, pero se estima que la infección se corresponde al 60% de las muertes en niños menores de 5 años. La sepsis puede presentarse sin foco evidente o con foco primario: Neumonía 50%, bacteriemia 19%, abdomen 8%, SNC 4%, ITU 4%.1

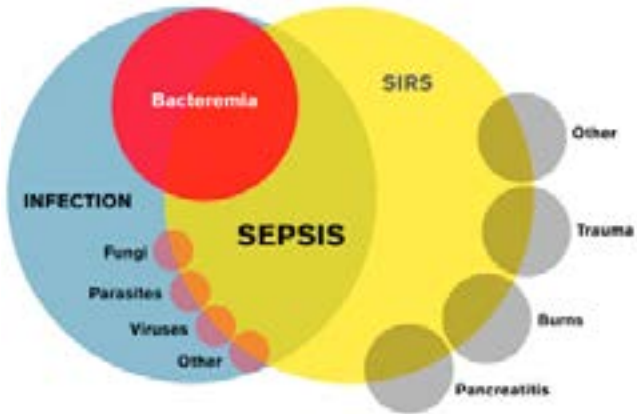
Definiciones (ver Tabla 1)

La sepsis es la respuesta sistémica a la infección. La etiología primaria, por lo tanto, se puede atribuir tanto al patógeno infectante como a la respuesta del huésped. Mientras que cualquier infección puede precipitar la sepsis, los patógenos más comunes son las bacterias, los virus y los hongos. El tipo de patógeno varía según los factores del huésped, como la edad, la comorbilidad y la ubicación geográfica.

Es decir, es provocada por una respuesta inmune inadecuada a una infección y se caracteriza por una falla de distintos sistemas, lo cual representa una importante amenaza a la vida.

Infección	ospecha o prueba de infección por cultivo/PCR de cualquier patógeno, o síndrome clínico compatible.
SIRS	Respuesta inflamatoria generalizada que se define con > 2 criterios: Temperatura <36°C o >38.5°C* Taquicardia Taquipnea Leucocitosis o leucopenia* *al menos uno de estos debe estar presente como criterio
Bacteriemia	Presencia de bacterias en hemocultivos
Sepsis	Sospecha clínica de infección + SIRS
Shock séptico	Sepsis asociado a hipotensión arterial que no responde al tratamiento con fluidos endovenosos y requiere de drogas vasoactivas

Tabla 1. Definiciones



Comentario

Hace más de 20 años se publicó la primera definición de sepsis basado en el concepto de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS), definición que utilizamos hasta la actualidad. Recientemente, el Grupo de Trabajo de las Definiciones de Sepsis ha publicado un consenso con las definiciones actualizadas de sepsis y shock séptico (SEPSIS-3) que utiliza un nuevo concepto de sepsis como disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, utilizando el sistema de puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), y propugna se abandonen los antiguos criterios (SIRS, sepsis severa).

Como se puede apreciar, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en torno a las definiciones para el diagnóstico de sepsis desde una clasificación de criterios basada en hallazgos clínicos, a una basada en fisiopatología. Los criterios diagnósticos basados en el diagnóstico de SIRS, si bien presentan una serie de limitaciones, tienen una gran virtud y es la de permitir la temprana sospecha de sepsis, algo que aún no sabemos si ocurrirá con relación a estos nuevos criterios propuestos. Entonces, en este escenario, sería prudente mantener ambos criterios en la práctica clínica hasta tener las correspondientes validaciones y la confirmación de que podemos sustentar el cambio de los antiguos criterios con la tan necesaria evidencia. 8

Fisiopatología

Se plantea un modelo secuencial expansivo (teoría de Roger Bone), en el que existe un desbalance entre los factores proinflamatorios y (posteriormente) los antiinflamatorios. En este modelo, en el transcurso de la sepsis, tiene lugar:

Activación de diferentes vías humorales: Cascada del complemento C3a, C5a, de la coagulación y de la fibrinólisis.

Activación de células de la respuesta inflamatoria, con amplificación de mediadores inflamatorios: factor de necrosis tumoral alfa (TNF), leucotrienos, tromboxano A2, prostaglandinas, interleuquinas 1, 6, 8P y 12 entre otras, interferón gamma, factor activador de plaquetas.

Los macrófagos cumplen un rol central.

Factores antiinflamatorios: interleuquinas: 4, 6, 10, 11 y 13.

La resultante final es una respuesta amplificada determinante de daño endotelial, con aumento de la permeabilidad vascular sistémica, por vasodilatación mediada por óxido nítrico, llevando a signos de disfunción multiorgánica.

Etiología

Debemos dividir los agentes etiológicos más frecuentes según edades, estado inmunitario y adquisición extra o intrahospitalaria.

Neonatos:

Sepsis precoz: ocurre en las primeras 72 horas de vida. Más frecuentes: estreptococos del grupo B y los bacilos Gram negativos (especialmente *Escherichia coli*). *Staphylococcus aureus* y estafilococos coagulasa negativos, *Haemophilus influenzae* y enterococos constituyen la mayoría del resto de las causas bacterianas. La infección causada por *Listeria monocytogenes* es rara, pero tiene una propensión desproporcionada para las mujeres embarazadas y sus fetos (puede ser responsable de la sepsis neonatal de inicio temprano o tardío).

Sepsis tardía: ocurre después de las primeras 72 horas a un mes de vida. Los estafilococos coagulasa negativos son la causa más común debido a la alta incidencia de infección asociada a catéter vascular en pacientes hospitalizados neonatales.

Características	Patógenos involucrados
De la comunidad, niño sano	<i>S. aureus</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>E. coli</i> , <i>Salmonella</i> sp.
Intrahospitalario, niño sano	<i>S. aureus</i> meticilino-resistente, <i>Staphylococcus coagulasa-negativo</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterobacter</i> sp., <i>P. aeruginosa</i> .
Inmunocomprometido	<i>S. aureus</i> , <i>S. coagulasa-negativo</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>Candida</i> sp.

Tabla 2. Tipo de agentes etiológicos de acuerdo con el lugar de adquisición de la infección y las características del huésped. 3

Manifestaciones clínicas

La presentación típica varía según factores de riesgo y edad del niño.

Los recién nacidos y lactantes menores de 3 meses suelen presentar síntomas y signos inespecíficos: mala regulación de la temperatura, rechazo de las tomas, apatía, ictericia, hipotonía, quejido, púrpura, distensión abdominal, convulsiones, apneas, entre otros.

En los lactantes mayores y en los niños, la sepsis se presenta típicamente con características de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS- Tabla 1), cuya característica más común es la fiebre. Hay ocasiones en que se puede distinguir un foco primario de infección: cuadro respiratorio, diarrea, vómitos, infección de piel y/o partes blandas, signos meníngeos, etc.

En el examen físico evaluar los diferentes aspectos:

Signos vitales: temperatura, hipoxia, hipotensión, taquicardia, taquipnea.

Piel: forúnculos, úlceras, celulitis, sitios intravenosos, púrpura o petequias, exantema, aspecto reticulado, coloración, estado de hidratación.

Respiratorio: taquipnea, mecánica ventilatoria, hemoptisis, semiología respiratoria.

Gastrointestinal: aspecto del abdomen, dolor o defensa abdominal, disminución de los ruidos intestinales.

Genitourinario: dolor suprapúbico, dolor lumbar, diuresis.

Cardiovascular: taquicardia, soplo, pulsos, rellenos capilares.

Neurológico: estado de conciencia, irritabilidad, fontanela, signos meníngeos.

Con frecuencia, el foco de infección puede no ser evidente, en especial en neonatos y en pacientes inmunocomprometidos.

Exámenes complementarios

Hemograma completo con recuento leucocitario diferencial: Un conteo de células bajo o normal es una característica de la fase inicial de la enfermedad en la sepsis grave al igual que fórmulas inmadura. La trombocitopenia en el contexto de sepsis es indicativo de coagulación intravascular diseminada si se asocia con coagulopatía.

Glucemia: La hiperglucemia es común como parte de la respuesta al estrés de la sepsis. También puede ocurrir como un efecto secundario

del tratamiento con corticosteroides. La hipoglucemia puede producirse como resultado del agotamiento de las reservas de glucógeno.

Hemocultivos: Debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible después del diagnóstico clínico de sepsis, e idealmente antes de que se administren antibióticos, pero el tratamiento antibiótico empírico no debe ser retrasado. Idealmente se deben obtener un mínimo de 2 hemocultivos (aeróbico y anaeróbico)

Análisis de orina y urocultivo: debe considerarse una muestra de orina para nitritos, microscopía, tinción de Gram y cultivo.

Gases de sangre: Aunque a los niños rara vez se les toma gasometría arterial en el servicio de urgencias, a menudo es posible obtener información clínicamente útil de los gases en sangre venosa o capilar. Un amplio déficit de bases es un marcador clave de la sepsis grave y puede ser el primer marcador para dar una pista sobre la gravedad de la enfermedad, sobre todo en un paciente que no presenta pérdidas como vómitos o diarrea.

Lactato sérico: un nivel de lactato sérico elevado es indicativo de un suministro inadecuado de oxígeno que, en el contexto de la sepsis, es sugerente de shock séptico. El lactato se evalúa de forma más fiable utilizando una muestra arterial; el lactato venoso y capilar debe interpretarse con cautela.

Electrolitos séricos: Deberían medirse al inicio y regularmente hasta que los pacientes mejoran.

Creatinina sérica: la creatinina aumentada es indicativo de falla renal relacionada con la sepsis.

Hepatograma

Coagulograma: en el contexto de sepsis y trombocitopenia, los resultados anormales son indicativos de diseminación intravascular diseminada.

Proteína C reactiva: Biomarcador, reactante de fase aguda, su elevación es predictor de infección de etiología bacteriana, útil para seguimiento de la evolución del paciente.

Procalcitonina sérica: Este biomarcador puede ser útil para el momento inicial diagnóstico como predictor de etiología bacteriana, y su curva para el seguimiento de la sepsis y el shock séptico, pero la prueba no está comúnmente disponible.

Panel Viroológico, PCR Bordetella Pertussis, PCR Mycoplasma pneumoniae en Aspirado de secreciones nasofaríngeas: según sospecha clínica

Disfunción cardiovascular

Tras administración de fluidos isotónicos ≥ 40 ml/kg en 1 h:

1. Presión arterial $< p5$ para su edad o PAS $< 2SD$ por debajo de normal para su edad
ó
2. Necesidad de drogas vasoactivas para mantener PA en rango normal
ó
3. Dos de los siguientes:
 - a. Inexplicable acidosis metabólica: déficit de base < 5 mEq/L
 - b. Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal
 - c. Oliguria $< 0,5$ ml/kg/h
 - d. Llame capilar > 5 "
 - e. Gradiente de T° central-periférica $> 3^\circ C$

Disfunción respiratoria

1. $PaO_2/FiO_2 < 300$, sin cardiopatía cianótica o enfermedad pulmonar previas
2. $PaCO_2 > 65$ mmHg (o 20 mmHg sobre la $PaCO_2$ basal)
3. Necesidad de $> 50\%$ de FiO_2 para $SatO_2 > 92\%$

Disfunción neurológica

Score de coma de Glasgow ≤ 11 o cambio brusco con descenso de ≥ 3 puntos desde un Score basal anormal

Disfunción hematológica

Recuento plaquetario $< 80.000/mm^3$ o descenso del 50% del valor previo anterior a 3 últimos días (en pacientes crónicos hemato-oncológicos) o relación internacional normalizada > 2

Disfunción renal

Creatinina sérica ≥ 2 veces por encima del límite para su edad o el doble de la basal

Disfunción hepática

Bilirrubina total ≥ 4 mg/dl (no en neonatos) o ALT 2 veces por encima del límite normal para su edad

Radiografía de tórax

Punción lumbar: si se sospecha meningitis por cuadro clínico. No se debe realizar en paciente clínicamente inestable. Tomar muestras para citofisicoquímico, cultivo y virológico.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) bacterianas en LCR: debido a la dificultad de aislamiento en cultivos, es una manera útil y rápida para rescatar microorganismo causal. No se encuentra ampliamente disponible.

PCR para virus Herpes simplex y otros virus en LCR.

Monitorización

Se debe realizar una monitorización continua del paciente hasta conseguir estabilidad hemodinámica:

Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria
ECG continuo

Tensión arterial
Oximetría de pulso
Temperatura
Nivel de conciencia
Diuresis (sondaje vesical)
Otros: Presión venosa central, saturación venosa central de oxígeno.

En la reanimación inicial los parámetros para monitorizar una adecuada consecución del objetivo de mantener el gasto cardíaco son clínicos: frecuencia cardíaca, relleno capilar, nivel de conciencia, tensión arterial.

Shock Séptico

Situación clínica caracterizada por disfunción cardiovascular produciendo baja perfusión y disminución de la oferta distal de oxígeno. Shock séptico es sinónimo de requerimiento de inotrópicos, a pesar de la adecuada resucitación con fluidos endovenosos, y/o no poder mantener el ácido láctico arterial por debajo de 2 mmol/l con

dicho tratamiento.

Clínicamente se manifiesta por alteración en la perfusión y su definición no señala la presencia de hipotensión arterial, ya que ésta no es necesaria para su diagnóstico clínico. La hipotensión arterial es un signo tardío y confirmatorio de shock séptico en niños.

¿Cuáles son las bases para el tratamiento de los pacientes con sepsis?

El tratamiento del niño con sepsis debe realizarse rápidamente ya que es una urgencia infectológica. Se indicarán medidas de sostén, de orden general y el tratamiento empírico con antibióticos, que se adecuarán o no según rescate microbiológico. (Tabla 4)

- ✓ Medidas de sostén: Medidas para mejorar perfusión de oxígeno a los tejidos
- ✓ Establecer el ABC de la reanimación, si necesario iniciar RCP o apoyo ventilatorio con intubación

Edad	Microorganismos	Antibiótico
0-3 meses	E.coli, Estreptococcus agalactiae, Enterococcus spp, Listeria monocytogenes, S.aureus, S.pneumoniae, N.meningitidis, Hib,	Ampicilina + Cefotaxime
3 meses – 5 años	S.aureus, S.pneumoniae, N.meningitidis, Hib	Ceftriaxona o Cefotaxime *agregar Vancomicina en áreas con alta resistencia a Metilina
Mayor de 5 años	S.aureus, S.pneumoniae, N.meningitidis	Ceftriaxona o Cefotaxime *agregar Vancomicina en áreas con alta resistencia a Metilina

Tabla 3. Antibioticoterapia empírica según agentes más frecuentes por edades (en la comunidad) 7

1	Medir el nivel de lactato en sangre. Reevaluar si el valor inicial es mayor a 2 mmol. Un nivel mayor puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno y puede identificar precozmente a un paciente con mayor riesgo de mayor deterioro.
2	Tomar Hemocultivos para identificar causa probable de infección. Se deben tomar antes de indicar antibióticos si fuera posible.
3	Administrar antibióticos de amplio espectro que sean activos contra los gérmenes más frecuentes según epidemiología, antecedentes y/o según foco clínico asociado.
4	Comenzar con líquidos por vía intravenosa. La reanimación con líquidos es un paso esencial para estabilizar la condición del paciente.
5	Vasopresores para elevar tensión arterial. Es un paso de resucitación crítico en pacientes con shock séptico.

Tabla 4. Sepsis “Paquete de medidas para la primera hora” 5

- ✓ Administrar oxígeno
- ✓ Monitorización
- ✓ Canalización de 2 vías periféricas o en su defecto vía intraósea (valorar sedoanalgesia)
- ✓ Fluidoterapia: cristaloides 40-60 ml/kg
- ✓ Las medidas de orden general que deben implementarse en cualquier paciente séptico deben establecerse durante la "hora de oro": es la primera hora desde que el paciente ingresa al sistema de salud, en la que debemos actuar para disminuir la morbilidad.
- ✓ Drenaje precoz de los focos sépticos (por ejemplo, abscesos, catéteres).
- ✓ Reanimación agresiva y rápida del shock.
- ✓ Escisión de tejidos necróticos.
- ✓ Optimización de la oxigenación tisular.
- ✓ Medidas para evitar la hipotermia.
- ✓ Medidas para tratar la hipertermia.
- ✓ Tratamiento del dolor.
- ✓ Implementación de un monitoreo adecuado.

Antibioticoterapia empírica: Uno de los puntos más relevantes del manejo de la sepsis es el tratamiento antibiótico. La elección se basa en la presunción del microorganismo causante, en las características del huésped y la adquisición intrahospitalaria o extrahospitalaria de la infección. Deben usarse dosis adecuadas de antibióticos bactericidas, de efectividad demostrada, dirigidos a la mayor cantidad de patógenos que podrían estar involucrados en el proceso infeccioso, de baja toxicidad y bajo costo. Además, se deberá evitar la administración intramuscular y adecuar las dosis a la insuficiencia renal o hepática acompañantes. Es prioritaria su administración durante la primera hora.

La duración del tratamiento antibiótico variará de acuerdo con cada situación. Por ejemplo, la duración del tratamiento para las bacteriemias primarias de la comunidad, sin foco clínico de infección, es en general de 10 días. En caso de que el paciente fuera valorado como séptico inicialmente y luego no se obtenga aislamiento microbiológico y el niño evolucione favorablemente, se sugiere completar un curso de tratamiento antibiótico no menor de 7 días. Si en la evolución se detecta una causa no infecciosa del síndrome de sepsis se suspenderán los antibióticos indicados inicialmente.

¿Se puede prevenir la sepsis?

El principal método de prevención primaria es la inmunización. Los programas de inmunización son iniciativas clave de salud pública en todas las regiones del mundo, pero existe desigualdad en términos de acceso a los productos vacunales existentes. El Plan de Acción Global de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud es un marco para reducir las muertes por infección a través de la mejora del acceso a las vacunas en todo el mundo.

La prevención primaria es también relevante en el ámbito de las infecciones asociadas con el cuidado de la salud. Dado que estas infecciones están relacionadas con intervenciones específicas (como la inserción de un catéter vascular), hay oportunidades para reducir el riesgo de infección a través de mejoras en la práctica clínica, como mejorar las prácticas de lavado de manos, el aislamiento de protección, y las precauciones universales.

En cuanto a prevención secundaria, se recomienda la profilaxis antimicrobiana a largo plazo con antibióticos, antivirales, o antifúngicos en pacientes inmunocomprometidos con condiciones premórbidas (tales como leucemia).

Conclusiones

La sepsis y el shock séptico representan uno de los principales problemas para la salud pública mundial. El trabajo en equipo, el reconocimiento clínico temprano y el tratamiento oportuno mejoran la gestión de la sepsis. Se debe tener en cuenta la aparición de signos y síntomas no suficientemente claros en la primera observación para detectarlo de manera temprana. La simplificación de los criterios de diagnóstico permitió una pronta identificación y mejor supervivencia de los pacientes.²

El reconocimiento oportuno y precoz de la enfermedad es imperativo. Se ha demostrado que la administración oportuna de antibióticos y de otras terapias de apoyo mejora el resultado, y que el tratamiento temprano agresivo debe iniciarse lo antes posible.

Comentario del especialista

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Si no

se reconoce y trata de forma temprana, puede provocar rápidamente la muerte. La carga epidemiológica global de la sepsis es difícil de determinar. Se estima que afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo cada año, lo que puede provocar 6 millones de muertes, principalmente en países de bajos y medianos ingresos.

La sepsis puede ser la manifestación clínica de infecciones adquiridas tanto en el entorno comunitario como en los centros de atención médica. Las infecciones asociadas a la atención de la salud son uno de los eventos adversos más frecuentes que se producen durante la prestación de atención y con mayor riesgo de mortalidad, ya que se asocian a microorganismos más resistentes.

La selección de un régimen antimicrobiano empírico óptimo en sepsis y shock séptico es uno de los determinantes centrales para reducir la mortalidad. La sobrevida disminuye hasta cinco veces con un régimen empírico que no cubre el patógeno responsable. Sin embargo, la elección es compleja y varios factores deben ser evaluados para determinar el antimicrobiano apropiado en cada centro médico y para cada paciente (por ej.: el sitio anatómico de infección, los patrones de resistencia de los patógenos prevalentes en la comunidad y el hospital, la presencia de defectos inmunes específicos, la edad y comorbilidades del paciente).

La resistencia a los antimicrobianos es un factor importante que determina la falta de respuesta clínica al tratamiento y la rápida evolución hacia el shock séptico y la muerte. Se cree que tres de cada diez muertes por sepsis neonatal son causadas por patógenos resistentes.

Se deben evaluar siempre ante un paciente séptico los factores de riesgo de infección por patógenos resistentes a múltiples fármacos, incluidos: hospitalización prolongada, uso reciente de antimicrobianos, antecedentes de

hospitalizaciones previas y de colonización y/o infección con organismos multiresistentes.

Cada institución debe formular esquemas antibióticos empíricos de amplio espectro frente a infecciones intrahospitalarias y de la comunidad y luego iniciar un desescalamiento terapéutico según cultivo, sensibilidad y respuesta clínica. Por ejemplo, si se inicia terapia combinada para el shock séptico, se recomienda continuar con monoterapia en respuesta a la mejoría clínica y / o evidencia de resolución de infección. El uso racional de antimicrobianos no sólo beneficia al paciente mejorando el pronóstico clínico, disminuyendo los eventos adversos y los días de estadía hospitalaria, sino que también beneficia a la comunidad reduciendo los índices de resistencia locales.

Referencias

- Kohn Loncarica G, Fustiñana A, Jabornisky R. Recomendaciones para el manejo del shock séptico en niños durante la primera hora (primera parte). *Arch Argent Pediatr* 2019;117(1):e14-e23.
- Levy, Mitchell; Evans, Laura, Rhodes, Andrew. *The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update CriticalCare Medicine: June 2018 - Volume 46 - Issue 6 - p 997-1000*
- Neira SAnchez, Elsa R y Malaga, Germán. Sepsis-3 y las nuevas definiciones, ¿es tiempo de abandonar SIRS?. *Acta méd. Peru* . 2016, vol.33, n.
- Paganini H. Tratamiento de la sepsis en pediatría: ¿qué debemos hacer? *Arch.argent.pediatr* 2003; 101(5)
- Plunkett Adrian, Jeremy Tong. *Sepsis in Children*. Fuente: *BMJ* 2015; 350: h3017
- Prusakowski MK, Audrey P. Chen, PNP. *Pediatric Sepsis. EmergMed-Clin N Am* 35 (2017) 123-138
- Sociedad Argentina De Pediatría. *Libro Azul de Infectología Pediátrica*. 2012.
- Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock* 2016.

*Dra. Mara Maydana Experta revisora

Médica Pediatra. Especialista en Infectología Pediátrica. Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS EN PEDIATRÍA

Hospital General Zonal de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela.
Residencia de Clínica Pediátrica



Dra. Érica Moreno

Médica Asistente de sala de internación

Dra. Yanina Lagala

Dr. Cristian Olivera

Ex Residentes

Dra. Leticia Caballero

Dra. Lizet Fernández

Dra. Julieta Pardon

Residentes de 2º año

Dra. Mara Maydana *

Experta revisora

Sumario

La Meningoencefalitis bacteriana (MB) es una emergencia infectológica, producida por la inflamación de las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal, en respuesta a la llegada de bacterias o productos bacterianos y que posee una alta morbilidad y mortalidad. El diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano son pilares en el manejo terapéutico de esta entidad clínica.

Caso clínico

Paciente de 2 meses de edad que ingresa al servicio de guardia por presentar registros febriles y rechazo al alimento de 2 días de evolución.

Antecedente de haber recibido 48 horas pre-

vias a la consulta las vacunas correspondientes a los 2 meses.

Antecedentes personales: RNT/PAEG. Embarazo controlado, no acredita serologías. Alta conjunta. Sin internaciones previas. Pesquisa neonatal de errores congénitos normal, FO pendiente, OEA ambos oídos no pasan. Vacunas acorde a calendario. Lactancia materna exclusiva.

Examen físico:

Paciente en REG, febril, hemodinamicamente estable, irritable, presenta rechazo al pecho. SV T 39°C FR45 x' FC145 x' Sat 98% Peso: 5,340 kg.

En suficiencia cardiorrespiratoria, taquipneico, taquicárdico, llanto constante, fontanela abombada, leve rigidez de nuca, deshidratación leve,

resto del examen físico normal.

Exámenes complementarios al ingreso:

Laboratorio de rutina: GB 5.100 (51%-37%) HB 6,5 HTO 18,7 P117000 EAB 7,44/40/35/27/3,7 Na 133 K 3,7 glucemia 92 urea 23.

Sedimento urinario: células regulares, leucocitos regulares, piocitos regulares.

Se interpreta cuadro clínico como Lactante febril con foco meníngeo. Se realiza HMC X2, urocultivo, punción lumbar (citofisicoquímico, cultivo y virológico). Se indica ceftriaxona 100 mg/kg/d.

Resultados:

LCR: turbio/purulento con 13.000 elementos, glucorraquia de 0,3 g/dl, proteinorraquia 2 g/dl.

Cultivo: Haemophilus influenzae tipo b productor de betalactamasas.

Hemocultivos x 2 negativos.

Diagnóstico final: Meningoencefalitis por Hib

Paciente cumplió tratamiento con ceftriaxona 10 días, fue dado de alta con buena evolución clínica sin complicaciones. Se realizó profilaxis a contactos.

Meningitis y meningoencefalitis

Definición:

La meningitis es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges. Un 80% ocurre en la infancia, especialmente en niños menores de 10 años. En la última década, con la introducción de nuevas vacunas frente a los gérmenes causales más frecuentes (Haemophilus influenzae tipo b, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae) y con el desarrollo de distintos antibióticos, ha disminuido la incidencia y mejorado el pronóstico de la infección, pero las secuelas y la mortalidad no han sufrido grandes cambios.

La meningoencefalitis es tanto la inflamación de las meninges como del parénquima cerebral, presentando en mayor o menor grado disfunción neurológica, disminución del nivel de conciencia, letargia, alteraciones en la personalidad o el comportamiento, convulsiones o focalidad neurológica.

Epidemiología:

Durante el año 2019, en la República Argentina se notificaron 248 casos de ME bacteriana hasta la semana epidemiológica 32, con una incidencia

acumulada de 0,6 por 100.000 habitantes y 266 casos de ME virales, con una incidencia acumulada de 0,6 por 100.000 habitantes, con un descenso del 30% y 60% respectivamente en cuanto al total de notificaciones en 2018.

Si bien la incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae b ha disminuido debido a la incorporación de la vacuna conjugada en 1998, hay que tener en cuenta que pueden observarse casos en niños que no han sido vacunados o con vacunación incompleta (3 dosis o menos). En 2018 se registraron 22 casos de ME por Hib, un 30% menos de casos con respecto al año anterior.

La tasa de meningitis meningocócica en los últimos años es alrededor del 1/100.000 en los últimos años, con aproximadamente 400 casos notificados por año. La disminución del número de casos observados no está relacionada con ninguna intervención de vacunación, salvo en el manejo de brotes a nivel local.

Etiología:

Se diferencian 3 grandes grupos:

1. Meningitis bacteriana
2. Meningitis viral
3. Meningitis tuberculosa

La sospecha etiológica es clave para el inicio precoz de la antibioterapia empírica. Para ello debemos considerar la edad del niño, enfermedades de base que pueda padecer y su estado inmunitario.

Meningitis Bacteriana:

Edad	Frecuentes	Menos frecuentes
Neonatos	Estreptococo grupo B (EGB) Bacilos entéricos gramnegativos: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Salmonella	Listeria monocytogenes, Enterobacterias.
Lactantes y niños < 5 años	S. pneumoniae, N. meningitidis	H. influenzae tipo b
Niños ≥ 5 años y adolescentes	S. pneumoniae, N. meningitidis	

Meningitis virales:
Enterovirus no polio A – D (50%)
Herpes virus: HSV1, HSV2, EBV, VVZ, CMV, HHV 6 - 8.

Paramixovirus: Sarampión, Parotiditis, Influenza.
Otros: HIV, HTLV – 1, Hantavirus, Virus Junín, Fiebre Amarilla, virus San Luis, virus West Nile, Dengue, Zika, Chikungunya.

Clínica:

Las manifestaciones clínicas de las meningitis son diferentes según la edad del niño; cuanto menor es, más sutil e inespecífica es la sintomatología. La clínica es aguda en la mayoría de las ocasiones, en algunos casos puede ser insidiosa y en una minoría puede ser rápidamente progresiva con mal pronóstico si no se interviene en las primeras horas.

Recién nacido: indistinguible de sepsis: fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, rechazo de tomas, vómitos o polipnea. Es posible que presente convulsiones, parálisis de pares craneales, apneas, fontanela abombada.

Lactante: cursan con fiebre o febrícula, vómitos, rechazo de tomas, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteraciones de la conciencia, convulsiones. En ocasiones rigidez de nuca.

Mayores de 1 año: forma clínica clásica: fiebre elevada, cefalea, vómitos, convulsiones, rigidez de nuca y signos de irritación meníngea:

Signo de Kernig: Es la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta la flexión de la cadera.

Signo de Brudzinsky: Es la flexión involuntaria de las rodillas cuando el examinador flexiona pasivamente la cabeza del paciente.



Diagnóstico

Punción lumbar y análisis citofisicoquímico de líquido cefalorraquídeo: Ante la sospecha clínica de meningitis, la punción lumbar (PL) es el único método para confirmar el diagnóstico y no debe posponerse excepto que exista alguna de las

contraindicaciones para la misma, a saber:

Inestabilidad hemodinámica
Signos de hipertensión intracraneal
Trombocitopenia < 50.000 plaquetas
Alteraciones de la coagulación
Infección en el lugar de punción

El cultivo puede ser positivo y el estudio citológico normal si la punción se realiza en una etapa temprana de la meningitis.

Una meningitis aséptica (líquido claro) de probable origen viral puede presentar pleocitosis con predominio de neutrófilos en la evaluación inicial y en una nueva punción 6-8 hs más tarde mostrar un cambio a predominio linfocitario.

Se debe realizar análisis citofisicoquímico, que incluye recuento de leucocitos (total y diferencial), proteinorraquia, glucorraquia. Además, se efectuará tinción de Gram y cultivo. La obtención de una muestra de sangre antes de la punción lumbar para determinación de glucemia es necesaria para analizar la relación glucorraquia/glucemia.

Pruebas de diagnóstico rápido: La prueba de aglutinación de partículas de látex es un método sensible que puede detectar la presencia de polisacáridos bacterianos en LCR, aún en pacientes que han recibido antibióticos con anterioridad. Se utilizan para detectar los antígenos de polisacáridos capsulares del *Haemophilus influenzae* tipo b, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* y estreptococo grupo B. Este examen es más sensible y específico para *Haemophilus influenzae* que para los demás gérmenes. Solo debe indicarse en caso de pacientes con sospecha de meningitis bacteriana y cultivo negativo.

Bacteriología: En el examen bacteriológico directo con coloración de Gram se pueden observar microorganismos en el 90-98% de los pacientes sin tratamiento antibiótico previo. En el cultivo el rescate de microorganismos alcanza 80-90% de los casos sin tratamiento previo. La administración de antibióticos orales, no altera el examen citológico ni las características tincionales con el método de Gram. Aún con antibióticos endovenosos y dosis adecuadas por 48-72hs, se mantiene el perfil bacteriano del LCR. Respecto al cultivo, se estima que la administración previa de antibióticos orales disminuye en un 10% la posibilidad de rescate.

Citofísicoquímico de LCR	ASPECTO	CELULAS	PROTEINAS	GLUCOSA
NORMAL	Cristal de roca Transparente	1-5 mononuclear (Varía según edad)	0.15-0.45 g/l	50-80 g/dl
BACTERIAS	Turbio	> 1000 predominio PMN	++++	Disminuida
VIRUS	Claro	< 300 predominio Mononucleares	+	Normal
TUBERCULOSIS MICOSIS	Variable	> 1000 predominio mononucleares	+++	Disminuida

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Se emplean secuencias de ácido nucleico específicas pudiendo detectar bacterias y virus con alta sensibilidad. Es especialmente valiosa en los pacientes que recibieron antibióticos previos a la Punción lumbar.

Otros estudios complementarios:

Hemograma
Estado ácido base
Ionograma
Función renal - hepatograma
Hemocultivos periféricos x 2
Tomografía Axial Computada: debe reservarse para aquellos pacientes que presenten focalización neurológica, alteración del estado de conciencia o en quienes se sospeche colección purulenta o hidrocefalia. La ecografía es útil en niños con fontanela anterior permeable.
Fondo de ojos
Electroencefalograma
RMN con y sin gadolinio

Tratamiento

Medidas generales:

1. Iniciar el tratamiento antibiótico precozmente tras la recogida de cultivos.
2. Monitoreo de signos vitales, diuresis, nivel de conciencia y focalidad neurológica.
3. Disminuir la hipertensión intracraneal: analgesia, cabecera de la cama elevada. Evitar la restricción de líquidos y las soluciones hipotónicas que pueden disminuir la presión de perfusión cerebral.

Tratamiento antibiótico:

Manejo antibiótico empírico del paciente con sospecha de meningitis bacteriana: es indispensable iniciar inmediatamente tratamiento utilizando un antibiótico bactericida, con buena penetración de la barrera hematoencefálica, que

alcance una adecuada concentración en LCR y cuyo espectro abarque los microorganismos posiblemente involucrados.

< 1 mes	Cefotaxime + ampicilina
1-3 meses	Cefotaxime + ampicilina
> 3 meses	Cefotaxime/ ceftriaxona
Patología neuroquirúrgica	Vancomicina + cefepime o meropenem
Inmunodeprimido	Ampicilina + cefepime +/- vancomicina

Manejo en el paciente con diagnóstico dudoso: En ocasiones no es fácil distinguir un proceso de origen viral de uno bacteriano por las características del LCR; en estos casos la medicación antibiótica puede posponerse hasta repetir la punción lumbar en 6 a 8 hs. Esto no es aplicable en pacientes menores de 1 año o clínicamente inestables; en estos casos debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico y repetir la punción lumbar en 6 a 8 hs, si persiste la duda se mantendrá el tratamiento antibiótico hasta obtener resultado del cultivo.

Corticoides: La dexametasona administrada en los 15 minutos previos y hasta los 60 minutos posteriores de la primera dosis de antibióticos parenterales, ha mostrado una disminución de las secuelas motoras y neurosensoriales en pacientes con meningitis por *Haemophilus influenzae*, además de una franca mejoría clínica en las primeras 24 horas con disminución temprana de la presión intracraneal, aumento de la presión de perfusión cerebral y disminución del proceso inflamatorio. La dosis recomendada es de 0,6-0,8 mg/kg/día, en tres dosis por dos días. En términos generales, los corticoides redujeron significativamente las tasas de mortalidad, pérdida de audición y las manifestaciones neurológicas.

Punción lumbar de control: No se recomienda la realización de punción lumbar de control, salvo excepciones.

Tratamiento ME viral: No existe tratamiento específico para esta etiología, a excepción de la ME ocasionada por HHV 1 y 2. Ante los mismos, se deberá indicar Aciclovir EV (En menores de 12 años 60 mg/kg/día cada 8 hs y en mayores de 12 años 30 mg/kg/día cada 8 hs) 21 días, recomendándose nueva Punción lumbar cercana a la finalización del tratamiento.

Complicaciones

La meningitis bacteriana tiene una mortalidad que alcanza un 4,5% en los países desarrollados, siendo más frecuente en las producidas por neumococo y meningococo. Las complicaciones más habituales son:

Cardiovasculares: sepsis, shock, CID

Neurológicas: Edema cerebral, convulsiones, parálisis de pares craneales, hernia cerebral o cerebelar, mielitis transversa, ataxia, trombosis de senos venosos, hemiparesias, absceso cerebral y colecciones o empiemas subdurales. Secreción inadecuada de hormona antidiurética

Puede haber secuelas hasta en una cuarta parte de los niños afectados, tan graves como la epilepsia o el retraso psicomotor, ceguera, siendo la sordera neurosensorial la secuela más frecuente.

Profilaxis a contactos:

Se define contacto cercano a los convivientes, a quienes hayan permanecido con el caso índice más de 4 hs diarias durante 5 días a la semana (jardines maternos, instituciones, etc.) y toda persona expuesta a secreciones orales del enfermo.

Streptococcus pneumoniae: la profilaxis postexposición no está indicada.

Neisseria meningitidis: se debe efectuar profilaxis postexposición en contactos cercanos dentro de las primeras 24 hs con rifampicina (< 2 meses: 10 mg/kg/dosis, niños mayores: 20 mg/kg/dosis, adultos: 600 mg/dosis) cada 12 hs por 2 días y en embarazadas ceftriaxone 250 mg IM en dosis única.

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) se debe efectuar profilaxis postexposición con Rifampicina a iguales dosis mencionadas anteriormente, vía oral por 4 días en una única dosis diaria.

Prevención

La vacunación tiene el objetivo de proteger de la enfermedad al grupo etario más vulnerable y con mayor riesgo de enfermar y morir, por ello se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de vacunación de nuestro país.

La vacunación de adolescentes es una estrategia complementaria que ofrece no sólo la protección directa del grupo vacunado, sino fundamentalmente la disminución de la transmisión de la bacteria desde los adolescentes (portadores más frecuentes del meningococo, en nariz y fauces) a los lactantes; ofreciendo así una protección indirecta para aquellos niños que no estén vacunados.

Actualmente dentro del calendario nacional de vacunación, se encuentran las vacunas para *Neisseria meningitidis* serotipo ACWY (Menveo), *Streptococcus pneumoniae* (prevenar13) y *Haemophilus influenzae* (pentavalente), siendo estos los responsables en edad pediátrica de la mayoría de los casos bacterianos. Fuera del calendario se encuentra, la vacuna para *Neisseria meningitidis* serotipo B.

Comentario del especialista

La Meningoencefalitis bacteriana (MB) es una emergencia infectológica, producida por la inflamación de las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal, en respuesta a la llegada de bacterias o productos bacterianos y que posee una alta morbilidad. El diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano son pilares en el manejo terapéutico de esta entidad clínica.

En niños sanos, los tres microorganismos que más comúnmente causan MB aguda hematogénica son *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* y *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib). Con la introducción en el calendario nacional de inmunizaciones de vacunas frente a estos patógenos (Vacuna Hib en 1998, vacuna neumocócica 13 valente en 2011 y vacuna meningocócica ACYW135 en 2015), la incidencia de la enfermedad ha disminuido a través de los años.

Todos los pacientes con sospecha de MB requieren internación y realización de punción lumbar. Si existen signos o síntomas que contraindiquen la punción lumbar ésta podría posponerse hasta realizar tomografía cerebral con contraste, siempre evaluando riesgo-beneficio

en el retraso de la administración del tratamiento antibiótico empírico. Las anomalías del LCR características de la MB incluyen: pleocitosis a predominio polimorfonuclear, hipoglucorraquia e hiperproteíorraquia. El examen directo, con tinción de Gram, resulta positivo en 25-90% de las muestras, dependiendo del inóculo. El cultivo de LCR detecta al menos un microorganismo en el 85-90% de los casos y los hemocultivos en alrededor de 50%. Los antibióticos previos a la toma de muestra reducen la sensibilidad de los cultivos.

La MB requiere tratamiento antibiótico empírico inmediato basado en el agente etiológico probable según la edad, la epidemiología y los patrones de resistencia locales. El antibiótico elegido debe ser bactericida y tener una concentración en LCR que supere 10 veces la concentración inhibitoria mínima (CIM) del microorganismo causal. La duración del tratamiento antibiótico varía según el microorganismo y la respuesta a la terapia utilizada.

A pesar del tratamiento antibiótico adecuado y las medidas adyuvantes un porcentaje de pacientes presentará secuelas neurológicas que van del 15 al 30%. Todos los pacientes requerirán de exámenes neurológicos, de desarrollo y de evaluación auditiva al finalizar el tratamiento y al menos a los 6-12 meses del egreso hospitalario.

Referencias

- Baquero Artigao F, R. Vecino López, F. del Castillo Martín. *Meningitis bacteriana*.
- Justo Ranera A, P. Soler-Palacín, M.G. Codina, C.R. Gonzalo de Liria. *Meningoencefalitis viral*.
- Sáez-Llorens X. *Patogénesis de la meningitis bacteriana. Implicaciones terapéuticas*.
- Comité Nacional de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría. *Meningitis bacterianas y enfermedad meningocócica*.
- Van de Beek D, de Gans J, McIntyre P, Prasad K. *Corticosteroids for acute bacterial meningitis*. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007; (1): CD004405.
- Sebire G, Cyr C, Echenne B. *Benefit of glucocorticosteroid in the routine therapy of bacterial meningitis in children*. *Eur J Paediatr Neurol*. 2006; 10(4): 163-6
- Mongelluzzo J, Mohamad Z, Ten Have TR, Shah SS. *Corticosteroids and mortality in children with bacterial meningitis*. *JAMA*. 2008; 299 (17): 2048-55
- Saez-Llorens X, McCracken GH, Jr. *Bacterial meningitis in children*. *Lancet*. 2003; 361(9375): 2139-48.
- Tzanakaki G, Mastrantonio P. *Aetiology of bacterial meningitis and resistance to antibiotics of causative pathogens in Europe and in the Mediterranean region*. *Int J Antimicrob Agents*. 2007; 29(6): 621-9.
- Casado J. *Meningismo. Infección meníngea*. En: Casado J, Serrano A, eds. *Urgencias y tratamiento del niño grave. Síntomas guía, técnicas y procedimientos*. 1ª edición. Madrid: Ergon; 2000. p. 351-9.

*Dra. Mara Maydana Revisora

Médica Pediatra – Especialista en Infectología Pediátrica. Hospital de niños Sor María Ludovica La Plata.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Hospital Zonal General de Agudos Argentina Diego de Azul



Dra. Itatí Bustamante

Dra. Ana Elisa Wagner

Dr. Néstor Cousté

Dra. Ana Clara Martínez

Revisora

Servicio de Epidemiología

Dra. Paz Sánchez Paz

Revisora

Servicio de Infectología

Sumario

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son producidas por más de 25 diferentes agentes infecciosos y continúan adquiriendo importancia en los últimos años por su gran incidencia anual a nivel mundial, así como por las consecuencias que acarrea.

En la prevención primaria contra las ITS se utilizan intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales, entre ellos: educación sexual integral, consejo sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, y fomento del uso de preservativos; intervenciones dirigidas a grupos de población específicos, como los trabajadores sexuales, los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables; y asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de los adolescentes.

SITUACIÓN CLÍNICA

G. C., de 14 años de edad, género femenino,

concorre a Servicio de Adolescencia tras presentar exantema generalizado de 7 días de evolución.

Antecedentes personales:

Sin antecedentes patológicos relevantes.

Pendiente 2da dosis de HPV

Menarca a los 12 años coincidiendo con inicio de relaciones sexuales.

Desconocimiento de su FUM, como así también del uso de métodos anticonceptivos.

Antecedentes familiares/sociales:

Familia numerosa en condiciones de hacinamiento, con fumadores activos. Padre con precariedad laboral.

Examen físico:

Pesa. 72 Kg Talla 158 cm TA: 120/70 mmHg

Adenopatías submaxilares indoloras, lesión en comisura labial izquierda de tipo ulcerativa e indolora y exantema macular generalizado.

Ante la sospecha de Sífilis, se solicitan las siguientes pruebas:

VDRL positiva 1/128 dils

HIV negativo

Comienza tratamiento con Penicilina IM.

Controles posteriores:

Clínico a la semana con mejoría de las lesiones.

Cumple esquema de tratamiento con Penicilina.

Testeo de una pareja NEGATIVO. PENDIENTE SEGUNDO CONTACTO.

Laboratorio: a los 3 meses VDRL 1/8. A los 5 meses 1/1

INTRODUCCION

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas causadas por microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos) que se transmiten, principalmente, por contacto de piel y mucosas o por intercambio de fluidos en las relaciones sexuales. (Ver cuadro I).

Algunas ITS afectan principalmente a los órganos genitales, pero también afectar a otras zonas como la anal, perianal y bucal, como así también generalizarse y comprometer a otros órganos del cuerpo. El contagio en mujeres embarazadas puede generar complicaciones en el feto y/o el recién nacido.

Es importante saber que muchas de estas infecciones pueden pasar inadvertidas, sobre todo al inicio, y que algunas de ellas pueden cronificarse o dejar secuelas permanentes.

Se encuentran entre las principales causas de enfermedad del mundo y continúan siendo un problema de salud pública con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran repercusión en muchos países. En América Latina, se ha observado un aumento de estas infecciones, con un claro predominio de la sífilis, que en el último tercio del siglo XX había descendido, asociado a las medidas preventivas que se generalizaron con la epidemia del VIH.

Todos los grupos etarios se ven afectados por las ITS, pero la mayor repercusión en cuanto a morbilidad se manifiesta en la población sexualmente activa. En este sentido, la población adolescente es altamente vulnerable, favorecido por diferentes factores de riesgo, como:

Menor uso de medidas de protección en las relaciones sexuales.

Falta de información sobre los riesgos en la forma de contraer las ITS.

Aumento de contactos de carácter sexual a través de las nuevas tecnologías (aplicaciones



de móviles, chats...)

Vulnerabilidad socio-económicas.

Mayor consumo de drogas y alcohol.

Aumento del turismo sexual.

Con frecuencia coexiste más de una ITS; al detectar una infección se debe investigar otras sin tener en cuenta los síntomas de presentación.

El diagnóstico de un caso en niños o adolescentes no sexualmente activos implica la evaluación de un posible abuso sexual, la identificación de contactos y la educación del paciente.

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una ITS en el mundo.

Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna ITS.

La farmacorresistencia, es un obstáculo importante que dificulta la reducción de las ITS en todo el mundo.

En este capítulo no se incluyen VIH ni hepatitis B, patologías que merecen una consideración especial.

“El pastor Syphilus fue castigado con la enfermedad por llevar una vida inmoral y llena de vicios”. Girolamo Fracastorius, de Verona, 1530.

Cuadro 1. Etiología de las infecciones de transmisión sexual.

Microorganismos	Entidad Clínica
I. Virales	
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Virus herpes simple tipo II (VHS)	Herpes genital
Virus del papiloma humano (VPH)	Condiloma acuminado
Citomegalovirus (CMV)	Infección cervical
Virus del molusco contagioso	Infección por citomegalovirus
Virus de la hepatitis B	Molusco contagioso
Virus de la hepatitis C	Hepatitis B
	Virus de la hepatitis C
II. Bacterianas	
Treponema pallidum	Sífilis
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrea
Chlamydia trachomatis	Uretritis, cervicitis
	Linfogranuloma venéreo
Haemophilus ducreyi	Enfermedad pélvica inflamatoria
Calimotobacterium granulomatis	Chancroide o chancro blando
Mycoplasma hominis	Granuloma inguinal
	Uretritis inespecífica
Mycoplasma genitalium	Vaginosis bacteriana
	Uretritis inespecífica, cervicitis
Ureaplasma urealyticum	Enfermedad pélvica inflamatoria
	Uretritis inespecífica, cervicitis
	Enfermedad pélvica inflamatoria
III. Hongos	
Candida albicans	Vulvovaginitis
	Balanitis
IV. Parásitos	
+ Protozoarios	
Trichomonas vaginalis	Tricomoniasis
Entamoeba histolytica	Amibiasis genital
+ Ectoparásitos	
Pediculus humanus	Pediculosis
Sarcoptes scabiei	Sarna o escabiasis

Perinatol. Reprod. Hum. vol.27 no.2 México ene. 2013

SÍFILIS

La sífilis es una infección producida por la bacteria *Treponema pallidum* (TP), Es de carácter sistémico, curable y exclusiva del ser humano que se transmite fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal.

Descubierta en 1905 por el médico militar berlinés Erich Hoffmann y del zoólogo Fritz Schaudinn, continúa siendo un problema mundial y desde los comienzos del siglo XXI se ha observado un aumento creciente de casos, a pesar de que el diagnóstico es sencillo y el tratamiento accesible.

Es un problema de salud pública, poniendo en evidencia diferentes barreras institucionales

y estructurales como también subjetivas (vergüenza, miedos, estigmatización, condiciones sociales de vida) que dificultan la consulta y el acceso a los servicios de salud.

La mayoría de las personas con sífilis no tienen conocimiento de la infección, pudiendo transmitirla a sus contactos sexuales. Esto ocurre debido a la ausencia o escasez de sintomatología, dependiendo ésta de la etapa de la infección.

La OMS considera que cada año hay 12 millones de casos nuevos de sífilis en todo el mundo, 3.000.000 en América latina y el Caribe.

La seroprevalencia de mujeres embarazadas VDRL (+) oscila entre el 0,02 % y el 4,5% en países desarrollados y entre el 3 y el 18 % en países más pobres.

En Argentina, según datos del Ministerio de

Gráfico 1 Evolución de tasa de notificación de sífilis temprana y sin especificar en varones y mujeres por 100.000 habitantes, Argentina (2013-2017)



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, módulo de vigilancia clínica (C2).

Salud y Desarrollo Social de la Nación la tasa de casos de sífilis reportados en varones y mujeres jóvenes y adultos se triplicó entre 2013 y 2017, ya que pasó de 11,7 a 35,2 por cada 100.000 habitantes. (Gráfico 1). Asimismo, la proporción de positividad en las pruebas de rutina que se realizan a embarazadas pasó del 2 por ciento al 3,2 por ciento en el mismo lapso.

Según las mediciones, en 2018 tuvimos una tasa de 50,3 por 100.000 habitantes, y la mayoría de los casos se dieron en población de 15 a 24 años.

Formas de contagio

Sífilis adquirida (por contacto sexual)

Sífilis congénita en cualquier etapa de la gestación.

La adquisición por vía hemática (rara en la actualidad).

La contagiosidad de una persona con Sífilis es prolongada e indefinida. No obstante, la posibilidad de transmisión es mayor durante las fases primaria, secundaria y latente (sobretudo temprano) de la infección.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad tiene un período de incubación promedio de 28 días (10 a 90 días) y se caracteriza por presentar diversas etapas:

Sífilis temprana: transcurre dentro del primer año de adquirida la infección y abarca los estadios primario, secundario y latente temprano.

Sífilis tardía: transcurre posterior al primer año de adquirida la infección, abarca los estadios latente tardío, latente de duración desconocida y terciario.

Infección primaria: Caracterizada por úlcera o chancro en el sitio de infección, la mayoría evolucionan a la siguiente etapa y solo algunos pueden no hacerlo.

Infección secundaria: Rash cutáneo generalizado, lesiones mucocutáneas y linfadenopatías.

Infección terciaria: Manifestaciones cardiológicas, oftálmicas (iritis, retinitis o neuritis óptica), auditivas o gomas.

Los períodos de latencia (ausencia de síntomas y/o signos) transcurren entre los estadios secundario y terciario, en los que se diagnostica únicamente por pruebas serológicas. El período de latencia pueden ser temprano, cuando se detecta dentro del año de adquirida la sífilis, o tardío, si se detecta más allá del año de la adquisición o se desconoce ese momento.

La infectividad de la sífilis por transmisión sexual es mayor (alrededor del 60%) en las etapas iniciales (primaria, secundaria y latente temprana), disminuyendo gradualmente con el paso del tiempo (latente tardía y terciaria).

Herpes simple

Es Virus de distribución universal. Existen dos subtipos HVS1 y HVS2. El HSV1 es el agente causal de lesiones orales como gingivoestomatitis y

faringitis, y el HSV2 de Herpes genital. El HSV2, usualmente, se adquiere por contacto sexual, por lo cual su prevalencia aumenta después de la adolescencia. En los últimos años también se han descrito infecciones de la cavidad oral por HSV tipo II y lesiones genitales por HSV tipo I.

Se transmite por contacto sexual directo requiriendo contacto del virus con la superficie mucosa intacta o lesionada. Los riesgos conocidos para la adquisición de Herpes genital son: edad del paciente, número de parejas sexuales, frecuencia de contactos sexuales, raza y estado socioeconómico.

La infección primaria por HSV puede ser clínicamente inaparente hasta en el 50 % de los casos. En los casos sintomáticos, el periodo de incubación varía entre 1 y 5 días. Además de los síntomas locales, se observa frecuentemente síntomas sistémicos de diversa severidad, incluyendo fiebre, cefalea, decaimiento y mialgias.

Infección primaria: En los genitales externos, las lesiones pueden presentarse en diferentes estadios de evolución incluyendo vesículas, pústulas, úlceras coalescentes dolorosas y costras. Además de las lesiones características se acompaña de dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y/o uretral acompañada de adenopatías regionales dolorosas. El tiempo promedio de resolución de las úlceras es de 2 a 3 semanas. HSV 1 y 2 también se asocia a infecciones anales y/o rectales sintomáticas o asintomáticas. Los síntomas incluyen dolor anorectal, secreción anal, tenesmo y constipación.

Tras la primoinfección, tanto si se expresa clínicamente como si es asintomática, el virus establece latencia en los ganglios sensoriales del sistema nervioso. Durante este periodo, entra en fase quiescente no replicativa, y por tanto, ni se excreta ni se contagia, y los antivirales disponibles son inactivos frente a él.

Recurrencias: El 90 % de las personas con una infección primaria sintomática por HSV 2 sufren de reactivaciones clínicas. La mediana de recurrencia es entre 4 y 5 episodios clínicos anuales con un rango de 5 a más de 10. El número de recurrencias por HSV 2 es mayor que por HSV 1.

En comparación con los síntomas de la infección primaria, los síntomas locales durante las recurrencias clínica son de menor intensidad y duración. En las horas a días previos a una recurrencia, son comunes los síntomas prodrómicos que varían en intensidad y duración. Los pacien-

tes describen desde un cosquilleo mucocutáneas en la zona donde se formaran las vesículas hasta un dolor excruciante (lancinante) referido a las nalgas, piernas o caderas. Es de notar que hasta un tercio de las recurrencias clínicas pueden presentarse con lesiones atípicas incluyendo fisuras lineales o úlceras serpiginosas sin la característica base de eritema.

Diagnóstico: La inspección de las lesiones es un elemento de importancia en la evaluación diagnóstica, sin embargo, es el menos sensible y específico. La confirmación de una infección por HSV puede realizarse por métodos serológicos y por cultivo de partículas virales o amplificación del genoma viral de material obtenido por el raspado de las lesiones. La detección del DNA viral es más sensible y costo efectivo que las técnicas de cultivo viral. El cultivo y la detección de DNA viral permiten además diferenciar HSV 1 y HSV 2. Los anticuerpos anti HSV 1 y HSV 2 aparecen dentro de las primeras semanas de la infección y persisten en forma indefinida. Se ha establecido que la sensibilidad para la detección de anticuerpos anti HSV 2 por técnicas de ELISA

Tratamiento del primer episodio de herpes genital.

	Dosis	Vía de administración
Aciclovir	400 mg, 3 veces/día, 7 a 10 días	Oral
Alternativa valaciclovir	1 gr, 2 veces/día, 7 a 10 días	Oral

Tratamiento de las infecciones recurrentes por herpes genital.

	Dosis	Vía de administración
Aciclovir	400 mg, 3 veces/día, 3 a 5 días 800 mg, 2 veces/día, 3 a 5 días	Oral Oral
Alternativa valaciclovir	500 mg, 2 veces/día, 3 a 5 días	Oral

es entre el 80 al 98 %.

Los diagnósticos diferenciales con otras ITS incluyen la sífilis, chancroide y escabiosis. Enfermedades sistémicas como úlceras aftosas, porfiria, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad de Behcet pueden en ocasiones presentar características clínicas semejantes al herpes genital.

Tratamiento: El objetivo del tratamiento es disminuir la duración de los síntomas y la gravedad de estos, acelerar la curación de las lesiones y acortar la excreción viral y, por último, disminuir el riesgo de recurrencias.

En los pacientes con enfermedad grave o complicaciones que requieren hospitalización se recomienda tratamiento con aciclovir EV con 5 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La administración tópica y oral concomitante no ofrece ninguna ventaja adicional a la oral.

Virus del Papiloma Humano (HPV)

Es un grupo de virus constituido por más de 100 serotipos que deben su nombre a que muchos de ellos producen papilomas (condiloma acuminado) comúnmente llamados “verrugas”, de naturaleza benigna. Sin embargo algunos tipos de HPV (serotipos 16 y 18 principalmente) son considerados carcinogénicos y están asociados a neoplasias ano-genitales.

El periodo de incubación varía entre 3 semanas y 20 meses. La mayoría de las infecciones por HPV son asintomáticas o subclínicas y pasan desapercibidas. El virus sin embargo persiste en las células y puede ocasionar anomalías conocidas como displasias anales y cervicovaginales que luego de años pueden malignizarse, por lo que son consideradas lesiones precancerosas.

Las lesiones vaginales, cervicales y anales intraepiteliales se encuentran asociadas con tipos de HPV de alto riesgo oncogénico: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 68, mientras que en las vulvas predominan los de bajo riesgo 6 y 11 que son los responsables de los condilomas, habitualmente asintomáticos, pero que pueden ser dolorosos, pruriginosos o friables según el tamaño y la localización anatómica.

Transmisión: La transmisión ocurre por contacto, por lo cual habitualmente el HPV en la región anogenital se adquiere a través de rela-

ciones sexuales.

Diagnostico presuntivo: El PAP no detecta al HPV en forma directa, sino los cambios celulares ocasionados por el mismo, aunque no en el 100% de los casos. En un 5% de casos puede resultar normal en pacientes que albergan una neoplasia. Si muestra displasia, será una biopsia la que confirme el cáncer cervical o lo excluya, lo cual puede ocurrir en hasta un 10-15 % de los casos.

Diagnóstico de certeza:

Determinación de ADN viral: Si los resultados del examen ginecológico y Pap indican que hay cambios anormales se solicita la determinación de ADN viral que, además de confirmar su presencia, permite conocer el tipo de HPV involucrado.

Biopsia: si la toma es realizada en el sitio adecuado permite excluir o confirmar el cáncer cervical. Para facilitar la obtención de la muestra se le aplica al cuello del útero una solución de ácido acético a través de una colposcopia, que tiñe toda área sospechosa de una coloración blanquecina y permite dirigir la biopsia.

Prevención:

1. Medidas generales que tienden a disminuir el riesgo de infección por HPV: Evitar o disminuir el comportamiento de alto riesgo sexual, disminuyendo el número de contactos sexuales, lo que también reduce la exposición a otras ITS. Abandonar o modificar el hábito de fumar. Adoptar hábitos alimentarios que incluyan alimentos de alto valor nutritivo. El Instituto Nacional del Cáncer recomienda dieta rica en frutas, beta caroteno, ácido fólico, Vitamina A y C.

2. Preservativo: No proveen una protección absoluta dada la presencia de papilomas en periné, escroto y región perianal, es decir en áreas no cubiertas por el preservativo, sin embargo su uso previene el contagio de las otras localizaciones así como de otras ITS.

3. Test de Papanicolau periódico. Es útil para evaluar cambios celulares que permitan actuar preventiva- o precozmente sobre una neoplasia.

El VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y puede adquirirse tempranamente con el comienzo de la actividad sexual. Es por ello que la protección temprana a través de la vacunación es la estrategia principal para su prevención.

La vacuna contra el HPV fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2011, destinada a las niñas de 11 años nacidas a

partir del año 2000, con el propósito de disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino (CCU). En el año 2014 se definió la transición de vacuna bivalente a cuadrivalente con el beneficio adicional de prevención de verrugas genitales. En el año 2015, considerando la evidencia científica disponible con respecto a inmunogenicidad y eficacia del esquema de dos dosis, las coberturas nacionales, las recomendaciones internacionales y las nacionales, se decide simplificar el esquema a dos dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y segunda dosis (0-6 meses) para aquellos que inician vacunación antes de los 15 años. Teniendo en cuenta que la vacunación en varones genera reducción de la transmisión del virus, que se traduce en protección de rebaño, y que HPV es la principal causa de cáncer de pene entre otros, la ampliación de la estrategia de vacunación previene enfermedades asociadas al VPH en ambos géneros.

Tratamiento: Existen varios tratamientos disponibles, pero no son totalmente efectivos siendo frecuentes las recidivas. Hay dos métodos: físicos y químicos. Entre los primeros, se encuentra la cirugía, la electrocirugía y el láser. El Procedimiento de escisión electroquirúrgica en bucle (LEEP) se utiliza en cuello, vagina y vulva. En la criocirugía se aplica nitrógeno líquido para congelar las lesiones cada 1 o 2 semanas. La tasa de curación del 50 a 100%.

Dentro del grupo químico encontramos a un derivado de la podofilina, el Podofilox y el 5-fluor-uracilo. La podofilina se aplica en solución al 10% sobre las verrugas, lavando las lesiones a las 12 horas de aplicación con jabones neutros. El Podofilox al 0,5% en solución o en gel se coloca dos veces por día durante tres días y se descansa cuatro, de ser necesario, se repiten hasta cuatro ciclos. El 5-fluor-uracilo se aplica en forma tópica al 5%.

El Imiquimod al 5% en crema es un inmunoestimulante de acción tópica, se utiliza por la noche durante 6 a 10 horas (se debe lavar la región por la mañana) tres veces por semana durante 16 semanas.

Trichomoniasis

Es la infección causada por el parásito protozoo Trichomonas vaginalis. La infección es asintomática en al menos un 50% de las muje-

res y un 70-80% de los hombres. La Trichomoniasis sintomática se manifiesta por una secreción vaginal o uretral, dolor pelviano, disuria y prurito genital.

Diagnóstico:

Microscopia en fresco: Observación inmediata de la secreción. La sensibilidad es del 60 -70%.

Test rápido para Trichomonas spp: Se basa en una inmunocromatografía sobre una tira reactiva que detecta antígenos de T.vaginalis en la muestra obtenida por hisopado vaginal. No requiere de microscopio y los resultados se obtienen en aproximadamente 10 minutos.

Búsqueda de Ácidos nucleicos: Este método no solo detecta T vaginalis sino que en la misma muestra vaginal puede encontrar Gardnerella vaginalis y candida albicans. La demora en los resultados es de aproximadamente 45 minutos.

Cultivo de secreciones: Es el método más sensible y específico. Es de elección en aquellas mujeres con sospecha de Trichomoniasis en que la microscopia fue negativa y en todos los casos en que se sospeche esta infección en hombres.

Tratamiento: La primera línea de tratamiento se basa en esquemas de monodosis de metronidazol o tinidazol, 2 gramos por vía oral. Se debe alertar al paciente que se abstenga de consumir alcohol durante el tratamiento y por 24 hs luego de suspendido el metronidazol y 72 hs luego de suspendido el tinidazol debido a los efectos adversos asociados a estos antimicrobianos.

El tratamiento de la pareja sexual mejora la respuesta terapéutica y disminuye la transmisión. Se aconseja evitar las relaciones sexuales hasta finalizado el tratamiento y curado los síntomas. No se recomiendan los tratamientos tópicos con gel u óvulos debido a la menor eficacia.

Neisseria gonorrhoeae

Es un diplococo Gram negativo, anaerobio, intracelular que puede infectar el epitelio columnar del cérvix, uretra, faringe y conjuntiva. La gonorrea es la segunda ITS bacteriana más frecuente y se transmite a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que tenga gonorrea, o bien de la madre al hijo durante el parto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el 2012, se produjeron 78 millones de nuevos casos en adolescentes y adultos de 15 a 49 años en todo el mundo.

Clínica: Tiene un periodo de incubación de 3

a 5 días y puede producir, uretritis y cervicitis. En el caso de los varones produce una uretritis purulenta, pero en el caso de las mujeres cuando infecta cérvix, esta infección puede ser asintomática en casi el 50% de los casos. Cuando la uretritis y cervicitis da como síntomas disuria, dispareunia, secreción cervical y vaginal, generalmente purulenta o sangrado post-coito.

Cuando afecta a la faringe, suele ser asintomático y en las relaciones orales pueden contagiarse. También puede producir proctitis con tenesmo, dolor, secreción purulenta o mucosa con las heces.

Descartar abuso sexual en niñas que presentan vulvovaginitis de causa infectocontagiosa.

La gonorrea es una enfermedad de notificación obligatoria desde 1960. Argentina cuenta con un sistema de vigilancia clínica para la notificación ante casos de secreción genital tanto en varones como en mujeres. Siendo esto una herramienta para estimar la prevalencia de gonorrea en nuestro país.

Diagnóstico: El diagnóstico se realiza con una tinción de Gram de la secreción donde se pueden objetivar los diplococos Gram negativos intracelulares y cultivo en medio de Thayer Martin modificado.

Tratamiento: El tratamiento de elección actualmente es una terapia dual con Ceftriaxona 500 mg intramuscular más azitromicina 1 gr. en monodosis.

En la última década, se han detectado fallas de tratamientos a cefalosporinas de espectro extendido (cefixima y Ceftriaxona), drogas consideradas de primera elección para el tratamiento. Por esta razón, es necesario, controlar la propagación de la resistencia a gonococo, indicando diagnóstico etiológico en los casos sospechosos.

Chlamydia trachomatis

Es una bacteria Gram negativa intracelular obligada. Es la ITS bacteriana más frecuente en todo el mundo, y se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos. La clamidia se transmite al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona con infección por clamidias, o bien de madre a hijo durante el parto.

Clínica: la infección sintomática en mujeres incluye flujo vaginal anormal, disuria y sangrado poscoital e intermenstrual. Signos clínicos co-

munes en el examen con espéculo incluyen friabilidad cervical y secreción. Los hombres generalmente presentan secreción uretral y disuria, a veces acompañada de dolor testicular.

Si no se trata, la mayoría de las infecciones genitales se resolverán espontáneamente sin secuelas pero pueden resultar en complicaciones graves, principalmente en mujeres jóvenes. La Infección puede ascender al tracto reproductivo superior y provocar salpingitis e infertilidad y epididimitis en hombres.

A nivel rectal puede manifestarse como una descarga, dolor o sangre en las heces, pero es asintomático en mayoría de los casos. Las infecciones orofaríngea se presentan como faringitis y dolor de garganta leve.

La infección el embarazo se asocia con parto prematuro y bajo peso al nacer. Puede provocar conjuntivitis neonatal e incluso neumonitis.

Diagnóstico: las muestras se realizan en cérvix, orina, recto, faringe. Se pueden realizar técnicas no moleculares como ELISA o inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales, técnicas moleculares como PCR, hibridación de ADN, aunque el Gold estándar es el cultivo en líneas celulares.

De acuerdo a la guía de ITS publicada por el CDC y vigente desde el 2010, se recomienda realizar tamizaje para infección asintomática por *C. trachomatis* a toda mujer menor de 25 años sexualmente activa (idealmente de manera anual). Así también, dicha institución lo recomienda a toda mujer mayor de 25 años que se considera en riesgo (nueva pareja sexual, múltiples parejas sexuales). Dicha recomendación se hace extensiva además a mujeres embarazadas, debiendo realizarse durante su primer control prenatal.

Tratamiento: azitromicina 1 g monodosis o doxiciclina 100 mg/12 horas durante 7 días.

Conclusiones

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son producidas por más de 25 diferentes agentes infecciosos y continúan adquiriendo importancia en los últimos años por su gran incidencia anual a nivel mundial, así como por las consecuencias que acarrea.

Sin embargo se debe tener en cuenta que habitualmente hay un subregistro en las notificaciones, ya que un número importante de casos

son asintomáticas, por lo cual no son reportadas. Por otro lado sus consecuencias debido a la morbilidad que ocasionan, generan un costo considerable.

A pesar de los considerables esfuerzos realizados a fin de identificar intervenciones simples para reducir las conductas sexuales de riesgo, continúa siendo difícil lograr cambios de comportamiento a este respecto.

En la prevención primaria contra las ITS se utilizan intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales, entre ellos: educación sexual integral, consejo sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, y fomento del uso de preservativos; intervenciones dirigidas a grupos de población específicos, como los trabajadores sexuales, los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables; y asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de los adolescentes.

El asesoramiento puede mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que se solicite atención o se aliente a las parejas sexuales a hacerlo.

Para interrumpir la transmisión de las ITS y prevenir la reinfección, es importante incluir en el manejo de los casos el tratamiento de las parejas sexuales.

Teniendo en cuenta que los más afectados son los adolescentes y adultos jóvenes sobre todo mujeres, se debe poner énfasis en que las infecciones no tratadas conducen en su mayoría a complicaciones severas como infertilidad, evolución adversa del embarazo, HIV/SIDA, hepatitis crónica, cirrosis y diferentes tipos de cáncer (linfoma, sarcoma de Kaposi, carcinoma hepatocelular), por lo que se considera que un manejo clínico efectivo de las ETS, lleva a mejoras en el sistema de salud, tanto sexual como reproductivo.

Bibliografía

- Artieda Comunión. Infecciones de transmisión sexual en el adolescente, lo que el pediatra de Primaria debe saber. En: AEPap (ed.). *Curso de Actualización Pediatría 2018*. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 201-207.
- Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud. *Vacunación contra el virus del papiloma humano (vph)* 2017.
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Argentina. *Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina*. Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, Secretaría de Gobierno de Salud, 2018.
- Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. *Guía de prevención y tratamiento de las infecciones congénitas y perinatales*. Buenos Aires. Argentina. 2010.
- Ministerio de Salud. *Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS)*.
- Organización Mundial de la Salud. *Guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual*.
- Organización Mundial de la Salud. *Infecciones de Transmisión sexual*. 2019.
- Organización panamericana de la salud. *Clamidiosis*.
- Sociedad Argentina de Infectología. *Recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de las Enfermedades de transmisión sexual*. 2010.
- Sociedad Argentina de Infectología. *Recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual*.
- Sociedad Argentina de Pediatría. *PRONAP de adolescencia*. Modulo 4. 2018.
- Zamoni, M; Ralph, C; García, P y Cuello, M. *La prevalencia actual de infección genital por Chlamydia trachomatis en adolescentes y mujeres jóvenes chilenas asintomáticas justifica la vigilancia periódica*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Medicina. *Rev. Chilena Infectol* 2016; 33 (6): 619-627.

FIEBRE SIN FOCO EN EL NIÑO DE 3 A 36 MESES

Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” de Berazategui



Dra. Carla Carmona

Dra. Julia Castello

Dra. Carolina García

Dra. Lorena Gianasio

Dra. Anabella Lamberto

Dra. Andrea Rodríguez

Dr. Fausto Martín Ferolla

Revisor

Sumario

Cuando el pediatra atiende a un paciente febril, lo prioritario es determinar cuál es el motivo de la fiebre, sabiendo que la amplia mayoría tendrá un proceso viral autolimitado sin complicaciones. Un niño que luce bien difícilmente cursa una enfermedad seria, solamente necesitará un pediatra con compromiso para su seguimiento y la detección de posibles desvíos en su evolución. Identificar precozmente a aquellos pacientes con mayor riesgo de IBG es el desafío. La posibilidad de una infección urinaria es lo primero a estudiar en el caso de que la fiebre persista sin encontrarse foco.

Es importante recordar que no hay parámetros clínicos ni estudios de laboratorio que, aislados o combinados, permitan confirmar o descartar con certeza la existencia de IBG en niños con FSF, por lo que el control clínico exhaustivo y reiterado es fundamental

Situación Clínica

Motivo de consulta: fiebre.

Enfermedad actual:

Tupac, varón de 20 meses de edad, es traído a la consulta por fiebre de 48 horas de evolución, asociada a decaimiento y rechazo parcial a la alimentación. Sus padres refieren que presentó catarro de vía aérea superior la semana previa.

Antecedentes perinatólogicos: nacido a término, parto vaginal, con peso adecuado, embarazo controlado, serologías negativas en los 3 trimestres. Familia continente y con acceso a centro de salud cercano.

Actualmente el niño presenta vacunas al día, pesa 12,5 kg (percentilo 75).

Sin antecedentes patológicos de relevancia.

Examen físico: Buen estado general, febril. Vigil y reactivo, sin signos de foco motor o meníngeo. Raimondi

11/11. Rosado, normohidratado. Buena entrada de aire bilateral y buena mecánica respiratoria. Ambos ruidos cardíacos presentes en 4 focos, normofonéticos. Relleno capilar menor a 3 segundos. Abdomen, blando, depresible, indoloro, sin visceromegalias palpables. No se constatan

adenopatías. Resto del examen físico sin particularidades. Ritmo catártico habitual, sin diarrea. Diuresis positiva.

Signos vitales: frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, temperatura 38 °C.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
¿Son necesarios estudios complementarios?

El paciente presenta fiebre sin foco evidente de infección. Debido a que la infección urinaria es la infección bacteriana grave o potencialmente grave más probable en estos casos, se le solicitó un análisis de orina y urocultivo. Se le explicó a los padres cómo tomar la muestra al aseo (sin bolsa colectora debido a que puede contaminarse), con adecuada higiene previa y en cantidad suficiente (al menos 10 ml).

Resultado del análisis de orina:

- Escasas células epiteliales, 12 leucocitos por campo. Cilindros hialinos aislados.

¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Indicaciones.

Por observarse leucocituria, con diagnóstico presuntivo de infección del tracto urinario, se le indica cefalexina 100 mg/kg/día por vía oral y antitérmico (paracetamol 10 mg/kg/dosis) en el caso de que esté molesto por la fiebre. Se cita para control clínico en 24 horas. Se revalorará la conducta de acuerdo a evolución clínica, resultado del cultivo y eventual antibiograma. Se dan pautas de alarma y se recomienda consultar precozmente ante cambios en el estado general.

Comentarios

Un comité de expertos de la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas definió a la fiebre como un estado de elevación de la temperatura corporal que generalmente es parte de una respuesta defensiva frente a la invasión de microorganismos o sustancias reconocidas como patógenas.

La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría y uno de los signos clínicos más comunes de observar en este grupo etario. En aproximadamente 20% de los casos, no se encontrará causa evidente al inicio del cuadro.

Se define como fiebre sin foco (FSF) a la enfermedad febril aguda sin causa evidente después

de una adecuada anamnesis y un examen clínico minucioso. Si bien la mayoría de las veces se debe a una enfermedad viral autolimitada que no requiere tratamiento específico, también puede estar ocasionada por una infección bacteriana grave (IBG): infección urinaria, bacteriemia oculta, neumonía, meningitis, enteritis, artritis, osteomielitis, entre otras.

Es importante definir qué pacientes con FSF tienen bajo riesgo de IBG, para evitar los inconvenientes relacionados a estudios, tratamientos e internaciones innecesarias (infecciones asociadas al cuidado de la salud, resistencia a antibióticos y factores socioeconómicos y psicológicos). A menor edad, mayor probabilidad de IBG. Dado que las manifestaciones clínicas, la prevalencia de IBG y los microorganismos involucrados varían con la edad, las pautas de atención inicial de los niños con FSF de 3 a 36 meses son diferentes a las de aquellos más pequeños.

Un niño de 3 meses o más con FSF en buen estado general difícilmente presente enfermedad grave. A esta edad, en la mayoría de los pacientes, serán suficientes una adecuada anamnesis, un detallado examen físico y un monitoreo clínico estricto, sin la necesidad de exámenes complementarios. Con el desarrollo de nuevas vacunas y su aplicación masiva, se documentan cada vez menos casos de IBG. Antes de la vacunación universal contra *Haemophilus influenzae* b, el riesgo de bacteriemia oculta oscilaba entre 2,8% y 11,6%. Luego de ésta, disminuyó a 0,9%-3%. En lugares con adecuadas coberturas, (incluyendo la vacuna contra *Streptococcus pneumoniae*), que alcanzaron tasas de bacteriemia oculta menores a 0,5%, se plantea actualmente la no realización de estudios sanguíneos en la evaluación de niños de esta edad con FSF.

Aproximadamente 0,02% de los pacientes de 3 a 36 meses con FSF >39°C tiene bacteriemia oculta por *Neisseria meningitidis*. La presencia de petequias o lesiones purpúricas fuera del área de Valsalva constituyen un signo de alerta.

La infección urinaria ha pasado a ser la enfermedad febril bacteriana potencialmente grave más frecuente.

Está presente en hasta el 9% de los casos. Su prevalencia varía según la edad y el sexo, y es más probable a mayor tiempo de evolución del cuadro sin encontrarse foco y con niveles de temperatura superiores a 39°C.

En la atención de estos pacientes, el objetivo

es identificar precozmente, considerando los antecedentes, las características de la enfermedad actual, el examen clínico y, en ciertos casos, los resultados de estudios, a aquel que posea mayor riesgo de IBG. Para la toma de decisiones, será fundamental verificar el estado de vacunación.

Hay consenso en la bibliografía en dar importancia al interrogatorio y al examen físico para detectar factores de riesgo y diagnosticar las diferentes enfermedades focales. A niveles más altos de temperatura, mayor es la posibilidad de IBG. La mayoría de las investigaciones, realizadas antes de la incorporación de las vacunas conjugadas, coinciden en valorar niveles $\geq 39^{\circ}\text{C}$. El valor de constatar la sonrisa social es relativo: un bebé que le sonríe a su pediatra difícilmente tiene algo serio, pero a veces ésto no se cumple. Plantea discusión la necesidad de realizar de un segundo examen luego de dar un antipirético u ofrecer el pecho o mamadera, siendo la persistencia de irritabilidad un signo de alarma.

La observación y el seguimiento clínico son imprescindibles. Con el propósito de objetivar este análisis, se han desarrollado escalas de observación clínica. La de la Universidad de Yale (Yale Observation Scale -YOS-) es la utilizada para los

niños de entre 3 y 36 meses de edad. La misma consta de tres parámetros de observación simple y tres de interacción. A cada uno de los 6 parámetros se le adjudica el puntaje que encabeza las columnas y se suman para obtener el valor final (ver tabla).

Con el resultado de la suma de los puntajes puede determinarse la probabilidad de que el paciente presente una IBG. Hasta 10 puntos el riesgo es menor al 3%, entre 11 y 15 puntos asciende a 28% y con 6 puntos o más, es mayor al 92%.

Anamnesis - Historia Clínica:

Se deben recabar los siguientes datos:

- Edad.
- Antecedentes personales y familiares: prematuridad, enfermedades crónicas, infecciones previas, internaciones, uso previo de antibióticos y/o corticoides, inmunodeficiencia conocida o sospechada.
- Características y tiempo de evolución de la enfermedad actual.
- Temperatura: detallar el nivel de temperatura alcanzado, el tiempo de evolución

Tabla 1. Escala de observación de Yale.

	PUNTAJE PARAMETROS	1.	3.	5.
1.	Calidad del llanto.	Fuerte con tono normal o contento. No llora	Sollozo o llanto apagado.	Llanto débil o quejido de tono agudo.
2.	Reacción al estímulo de los padres.	Llanto breve o permanece alegre.	Llora a ratos, se adormece y luego cuesta despertarlo.	Sigue llorando o la respuesta es de difícil obtención.
3.	Variación del estado.	Si está despierto sigue despierto. Si está dormido, se despierta fácilmente.	De a ratos se adormece y luego cuesta despertarlo.	Tendencia al sueño. Si está dormido es casi imposible despertarlo.
4.	Color.	Rosado.	Extremidades pálidas o acrocianosis.	Pálido cianótico o moteado térreo.
5.	Hidratación.	Piel normal. Ojos normales. Mucosas húmedas.	Piel normal. Ojos normales. Mucosas ligeramente secas.	Piel pastosa. Ojos hundidos. Mucosas secas.
6.	Reactividad social al hablarle o sonreírle.	Sonríe o se muestra alegre.	Sonrisa leve alerta breve.	No sonríe. Facies ansiosa, embotada, poca expresividad, o no

y la frecuencia de los registros diarios de fiebre.

- Estado general: nivel de actividad y conciencia, características del llanto, posibilidad de ser consolado, actitud y tolerancia a la alimentación.
- Signos y síntomas asociados.
- Características de la diuresis y catarsis.
- Desencadenantes epidemiológicos, vacunaciones previas. Concurrencia a jardín maternal.
- Estado de vacunación.
- Nivel socioeconómico. Accesibilidad al centro de salud.

Examen físico:

- Inspección y escala de observación de Yale
- Exploración (en busca de foco y/o signos de gravedad):
 - Piel (color, exantemas, petequias, abscesos, celulitis).
 - Pulsos. Perfusión.
 - Auscultación cardíaca y pulmonar. Valoración de la frecuencia cardíaca y respiratoria.
 - Adenopatías.
 - Palpación abdominal y de genitales.
 - Movilidad de las extremidades.
 - Signos meníngeos. Fontanela. Examen neurológico completo.
 - Otoscopia. Observación de las fauces - boca.

Luego de evaluar todos los ítems mencionados, se puede definir al paciente con bajo riesgo de IBG a aquel que:

- No posea antecedentes patológicos significativos ni compromiso inmunológico.
- Se encuentre en buen estado general, con una YOS <10.
- Esté adecuadamente vacunado.
- Tenga registros febriles <39°C y < 24-48 horas de evolución.

No se justifica la realización de estudios complementarios en niños con fiebre sin foco de entre 3 a 36 meses de edad que cumplan con estas características.

Debido a su frecuencia, la primera IBG a descartar es la infección del tracto urinario, por lo que se recomienda realizar un análisis de orina completo y urocultivo en caso de fiebre sin foco

de más de 24-48 horas de evolución, fiebre elevada ($\geq 39^\circ\text{C}$) o antecedentes de infección urinaria.

Si el análisis de orina es normal, se debe considerar realizar un hemograma y medir los niveles sanguíneos de proteína C reactiva o procalcitonina (especialmente en los menores de 6 meses o no adecuadamente vacunados).

Los parámetros de laboratorio tradicionalmente utilizados como predictores para determinar alto riesgo de IBG son:

- recuento de leucocitos <5.000 o $\geq 15.000/\text{mm}^3$,
- recuento de polimorfonucleares totales $\geq 10.000/\text{mm}^3$,
- recuento absoluto de cayados $\geq 1.500/\text{mm}^3$,
- relación entre el recuento de cayados y el de los polimorfonucleares totales $\geq 0,2$,
- presencia de vacuolas y/o granulaciones tóxicas en los polimorfonucleares.

Éstos fueron descriptos para predecir IBG en investigaciones realizadas antes de la incorporación de las vacunas contra *Haemophilus influenzae b* y *Streptococcus pneumoniae*. Su sensibilidad y especificidad son menores en niños con infección invasiva por otras bacterias como *Neisseria meningitidis*, bacilos Gram negativos o *Staphylococcus aureus*. La proteína C reactiva y la procalcitonina son los reactantes de fase aguda más considerados en trabajos recientes, aunque valores normales de éstos no descartan IBG. La proteína C reactiva comienza a elevarse pasadas las 12 horas del inicio de la enfermedad, con valores altos en casos de IBG. Niveles ≥ 20 mg/L se asocian a mayor riesgo. La procalcitonina asciende más velozmente que la proteína C reactiva, con pico a las 6-8 horas, alcanzado una meseta a las 12 horas y descendiendo a las 48-72 horas del inicio del tratamiento adecuado y/o de la mejoría clínica. Valores menores a 0,05 ng/ml se relacionan con bajo riesgo de IBG, valores mayores a 2 ng/ml con sepsis.

A los pacientes con FSF de entre 3 a 36 meses que presenten resultados de laboratorio de alto riesgo se les deben realizar dos hemocultivos, aunque no necesariamente requieren ser internados si se encuentran en buen estado general.

Niveles de leucocitos $\geq 20.000/\text{mm}^3$ se vinculan con una mayor probabilidad de neumonía oculta, por lo que la solicitud de radiografía de tórax debe reservarse sólo para estos casos.

¿Cuándo indicar tratamiento antibiótico empírico? ¿A quiénes internar?

El paciente que se encuentra en mal estado general (YOS ≥ 10) tiene que ser hospitalizado, se le deben tomar 2 hemocultivos, urocultivo y realizar punción lumbar (ver figura). Estos estudios no deben demorar el inicio del tratamiento con 80-100 mg/kg/día de ceftriaxona, cuya indicación se reevaluará según la evolución clínica y el resultado de los cultivos.

Los pacientes con FSF de menos de 24 horas de evolución y buen estado general pueden ser observados ambulatoriamente, siempre y cuando sus padres comprendan las pautas de alarma y su seguimiento esté asegurado, sin solicitar estudios complementarios ni iniciar tratamiento antibiótico empírico.

Como mencionamos previamente, en caso de FSF que persiste por más de 24-48 horas, es recomendable realizar un análisis de orina y urocultivo. Con sedimento urinario patológico y de acuerdo con el estado clínico, puede iniciarse tratamiento por vía oral (100 mg/kg/día de cefalexina) en forma ambulatoria, que se adecuará o suspenderá según el resultado del urocultivo.

Si el sedimento urinario es normal, la realización del hemograma y medición de los niveles de proteína C reactiva o procalcitonina deben ser considerados, especialmente en aquellos menores de 6 meses, con fiebre alta ($\geq 39^\circ\text{C}$) y/o vacunación incompleta para *Haemophilus influenzae* b y/o neumococo (recordar que es fundamental el refuerzo posterior al año de las vacunas frente a estos patógenos). Si los resultados son de bajo riesgo, el paciente será controlado ambulatoriamente, sin indicación de antibióticos. Si algún parámetro de laboratorio define alto riesgo de IBG, se tomarán 2 hemocultivos (además del urocultivo) y se solicitará radiografía de tórax cuando el recuento de leucocitos sea $\geq 20.000/\text{mm}^3$. En niños de esta edad que se encuentren en buen estado general pero con parámetros de laboratorio de riesgo, varias publicaciones avalan el abordaje ambulatorio, incluso sin antibióticos, siempre y cuando sean posibles controles periódicos minuciosos que incluyan la lectura de los cultivos realizados. El tratamiento empírico con ceftriaxona 50 mg/kg/día es una conducta a considerar en pacientes en buen estado general definidos como de alto riesgo, especialmente en los menores de 6 meses, aquellos con temperatura elevada ($\geq 39^\circ\text{C}$) y ante la falta de cober-

tura adecuada frente a *Haemophilus influenzae* b y/o neumococo. Éste debe suspenderse a las 48 horas con lectura negativa de los cultivos o readecuarse de acuerdo a la evolución clínica, a la positividad de los cultivos y el resultado del antibiograma y/o ante la presencia de infección focal.

No es necesario realizar estudios complementarios adicionales ni iniciar antibioticoterapia en aquellos pacientes en buen estado general que requieran internación por causa social (imposibilidad de ser llevados a los controles, difícil acceso a la atención rápida en caso de desmejoría, padres que no comprenden las pautas de alarma, etc.).

Conclusiones

Cuando el pediatra atiende a un paciente febril, lo prioritario es determinar cuál es el motivo de la fiebre, sabiendo que la amplia mayoría tendrá un proceso viral autolimitado sin complicaciones. Un niño que luce bien difícilmente cursa una enfermedad seria, solamente necesitará un pediatra con compromiso para su seguimiento y la detección de posibles desvíos en su evolución. Identificar precozmente a aquellos pacientes con mayor riesgo de IBG es el desafío. La posibilidad de una infección urinaria es lo primero a estudiar en el caso de que la fiebre persista sin encontrarse foco.

Es importante recordar que no hay parámetros clínicos ni estudios de laboratorio que, aislados o combinados, permitan confirmar o descartar con certeza la existencia de IBG en niños con FSF, por lo que el control clínico exhaustivo y reiterado es fundamental.

Bibliografía

- Bruno M, Ellis A, Ferolla FM y col. Consenso para el uso adecuado de antibióticos en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco de infección evidente. *Arch Argent Pediatr* 2017; 115 Supl 2: S27-28.
- Ferolla F. Bacteriemia y gravedad. En: *Fiebre en Pediatría. Grupo de Trabajo "El Niño Febril", Región Metropolitana, Sociedad Argentina de Pediatría. Fundación Sociedad Argentina de Pediatría. 1º edición. Buenos Aires. 2006; pág. 33-39.*
- Reichenbach, Fontana, Gómez. *Pediatría en Red, Tomo 1. Capítulo 36. Vol: 1. La Plata, 2015. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.*

VACUNAS. OPORTUNIDADES PERDIDAS

Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro de Junín.
Residencia de Clínica Pediátrica



Dra. Ana M. Olmos
Dra. Elizabeth Fadda
Dr. Silvina Frino
Dr. Daniel Portero
Dra. Gisela Marchetti
Dra. Jorgelina Mancha
Dra. Tania Salazar

Dra. Magdalena Galetovich
Dra. Elizabeth Vargas
Dra. Belén Pirloni
Dra. Fiama Schechtel
Dra. Agustina Zarantonelli
Dra. Soledad Martiren
Revisora

Sumario

La importancia de evitar oportunidades perdidas de vacunación, aprovechando las oportunidades que se presenten para vacunar a la población, impidiendo que haya niños que queden sin recibir oportunamente la vacunación.

Involucrar activa y considerablemente al personal de salud, promover el cambio de actitudes en la población, utilizando la imagen y credibilidad de los mensajes que difunden líderes civiles y religiosos, autoridades locales y educadores.

- Modificar las actitudes del personal de salud para que la vacunación sea activa y no pasiva mejorando la comunicación entre profesionales de salud y la comunidad

Situación clínica

Ricardo, lactante de 3 meses de edad cronológica, a quien se le diagnostica hace una semana obstrucción bronquial leve, concurre a control.

Antecedentes: RNPT 28 semanas de gestación PN 1200 Kg. Alta a las 40 semanas de edad corregida con 2500 g. Permaneció en ARM. DBP, recibiendo Palivizumab. Cuadros de obstrucción

bronquial a repetición. Recibe leche maternizada y concurre a guardería.

Hermano de 7 años con insuficiencia renal crónica.

Examen físico:

Buen estado general, presenta buen crecimiento y desarrollo. Buena evolución del cuadro respiratorio, leve CVAS.

Al controlar el carnet de vacunas se observa que recibió solamente Hepatitis B al nacimiento, BCG aunque no se observa cicatriz y a los 2 meses la primera dosis de Pentavalente e IPV. Refiere que en el vacunatorio le dijeron que a su hijo por ser prematuro no puede recibir las vacunas del calendario nacional hasta los 4 meses y que por haber recibido Palivizumab esta, podría interferir con las vacunas de calendario.

Además sugieren recolocar BCG por ausencia de cicatriz.

Reflexiones

1 ¿Qué opinión le merece los comentarios recibidos por la madre con respecto a la vacunación de su hijo?

La información administrada es errónea porque en niños prematuros, aunque la respuesta a la vacuna es variable, se deben aplicar las vacunas correspondientes a la edad cronológica según Calendario Nacional de Inmunizaciones. Por lo tanto Ricardo debería tener colocadas las vacunas del nacimiento, las de los 2 y de los 3 meses.

La vacuna BCG es una vacuna a bacterias vivas atenuadas, de aplicación intradérmica a nivel del deltoides. Está indicada al nacimiento en dosis única y confiere inmunidad frente a las formas graves de tuberculosis. La misma puede administrarse a partir de los 1500 gramos y la edad máxima para su aplicación son los 6 años, 11 meses y 29 días. Generalmente deja cicatriz, aunque la ausencia de la misma no significa falta de inmunización. Por tal motivo, Ricardo no debería revacunarse a pesar de no presentar cicatriz.

Respecto al Palivizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado que confiere inmunidad contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) mediante la administración pasiva de anticuerpos. Se aplica en 4 dosis mensuales a la población de riesgo desde el mes de abril a septiembre (estación del VSR). Se considera población de riesgo según las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación del 2017:

- Prematuros menores o igual a 32 semanas de edad gestacional o con peso al nacimiento menor o igual a 1500 gramos, hasta los 6 meses de edad cronológica al inicio de la temporada de administración del anticuerpo, es decir, los nacidos a partir del 1º de noviembre del año anterior al de la campaña en curso.
- Prematuros menores a 29 semanas de edad gestacional (no menor o igual) y menores de 1000 gramos de peso de nacimiento (no menor o igual) que cumplan los dos requisitos de peso y edad gestacional hasta los 12 meses y 0 días de vida al inicio de la temporada de administración del anticuerpo, es decir, los nacidos a partir del 1º de mayo del año anterior al de la campaña en curso.
- Prematuros con diagnóstico de displasia broncopulmonar y requerimiento de oxígeno suplementario hasta los 12 meses y 0 días de vida al inicio de la temporada de administración del anticuerpo, es decir, los nacidos a partir del 1º de mayo del año anterior al de la campaña en curso.
- Niños de edad menor o igual a 12 meses y 0 días con cardiopatías congénitas que presenten inesta-

bilidad hemodinámica significativa* al inicio de la temporada de administración del anticuerpo.

A diferencia de los productos como Gamaglobulina hiperinmune, gamaglobulina inespecífica y hemoderivados, los anticuerpos monoclonales antiVRS (palivizumab) no inhiben la respuesta a las vacunas a virus vivos atenuados, dada su especificidad exclusiva para el VRS. Si bien a la edad del paciente del caso clínico no le corresponde ninguna vacuna de este tipo, vale la pena mencionarlo. Tampoco se observó interferencia en la respuesta a las vacunas inactivadas ante la administración simultánea o diferida, por lo que puede coadministrarse con otras vacunas del Calendario Nacional.

2 ¿Cuál sería el esquema de vacunación que debería recibir?

De acuerdo al Calendario de Nacional de Vacunación 2019, Ricardo debería recibir la vacuna contra Rotavirus, antineumocócica conjugada 13 valente, antimeningocócica tetravalente, además de las recibidas (quíntuple e IPV)

En Argentina, todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias y gratuitas.

3 ¿Qué le Interrogaría a la madre con respecto al esquema de vacunación del hermano?

En primer término habría que interrogar la causa de la insuficiencia renal crónica, entre otros motivos, para ver si recibe tratamiento inmunosupresor.

Independientemente del tratamiento, los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica presentan aumento de susceptibilidad a las infecciones por anomalías inmunológicas, deficiencias nutricionales y diálisis.

Sería importante corroborar calendario de vacunas ya que es un paciente de riesgo, teniendo en cuenta que presentan indicaciones especiales como:

- ✓ Vacunación antineumocócica: esquema secuencial VCN13 → VPN23 con un intervalo mínimo de 8 semanas luego de la VCN13. Refuerzo con VPN23 a los 5 años
- ✓ Vacunación antigripal anual.

Cuando se evalúa a estos pacientes se debe tener en cuenta que dentro de la protección debemos incluir siempre a sus contactos directos familiares en el programa de vacunación.

Las vacunas triple viral, antivariela y antigripal deben ser administradas a las personas susceptibles en contacto con pacientes inmunodeprimidos. Los virus vaccinales de la triple viral no se transmiten a los contactos, y la transmisión del virus de la vacuna antivariela es infrecuente.

En caso de tratamiento inmunosupresor, la vacuna antipoliomielítica oral está contraindicada dado que es una vacuna a virus vivo y presenta riesgo de transmisión horizontal. En este caso se debe indicar vacuna IPV al paciente y a la familia.

4) ¿Qué debería tenerse en cuenta entre la inmunización de su hermano y el tratamiento de su patología de base?

La respuesta a la vacunación está limitada por la misma inmunodeficiencia que limita la respuesta inmune a la enfermedad, variando con relación a la causa de IRC, el tratamiento y el grado de fallo renal. Los pacientes en diálisis presentan menores tasas de seroconversión, menor pico y rápida declinación de los títulos de anticuerpos, por lo que puede ser necesario mayor dosis o número de dosis para asegurar la protección. (ver cita)

El tratamiento con corticoides a altas dosis (prednisona >2mg/kg/día o 20 mg día en días y en forma prolongada (más de 14 días continuos) se asocia con inmunosupresión. Estos pacientes pueden recibir vacunas inactivadas, si bien la respuesta puede ser subóptima. De existir esta hiporrespuesta o pérdida temprana se podrá plantear la revacunación o el cambio en la vía de administración.

En cambio no deben recibir vacunas a microorganismos vivos. Las mismas podrán ser administradas a partir del mes de finalizado el tratamiento corticoideo en situaciones epidemiológicas especiales, aunque en términos ideales debería hacerse después de los 3 meses.

En caso de inicio programado del tratamiento inmunosupresor, éstas deberán aplicarse al menos 15 días antes de iniciado el mismo.

Dosis menores de corticoides sistémicos, el uso en días alternos, los corticoides de uso tópico, inhalatorio o intraarticular no se asocian con inmunosupresión y no deben ser motivo para no indicar las vacunas a virus vivos atenuados.

Conclusiones

Lo Importante para evitar oportunidades per-

didadas de vacunación:

Aprovechar las oportunidades que se presentan para vacunar a la población, impedir que haya niños que queden sin recibir oportunamente la vacunación.

Involucrar activa y considerablemente al personal de salud, buscando siempre a los niños a vacunar y a la población general en las actividades de vacunación.

Que el personal de salud esté bien capacitado y tenga siempre oportunidades de actualizarse mediante la lectura de reportes técnicos, asistencia a charlas, a conferencias, cursos y participando en reuniones de personal para el análisis del desempeño

Promover el cambio de actitudes en la población, utilizando la imagen y credibilidad de los mensajes que difunden líderes civiles y religiosos, autoridades locales y educadores. • Modificar las actitudes del personal de salud para que la vacunación sea activa y no pasiva mejorando la comunicación entre profesionales de salud y la comunidad

Las causas más comunes de las pérdidas de vacunación se pueden agrupar en 3 grandes grupos:

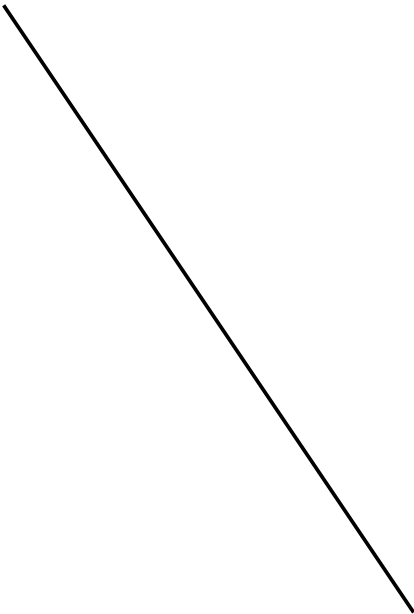
1 - Por parte del paciente: falta de información sobre los beneficios de las vacunas, escasez de recursos para acceder al sistema de salud, razones culturales, mitos y creencias, analfabetismo.

2 - Por parte del personal de salud: falta de conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de las vacunas, falta de tiempo, menor compromiso, falta de corroboración del estado de inmunización del paciente.

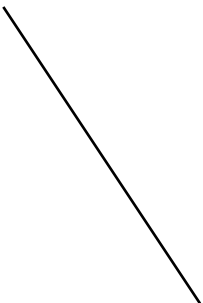
3 - Por parte del Estado: fallas en la provisión de vacunas, incumplimiento de la cadena de frío, falta de inversión de dinero en campañas de vacunación y elaboración de vacunas, falta de distribución proporcional de vacunas.

Bibliografía

- Guías SEN para el manejo de la enfermedad renal crónica avanzada y pre-dialisis.
- Ministerio de salud de la Nación. Aplicación de Palivizumab para la prevención de IRAB en población vulnerable. Campaña 2017.
- Ministerio de salud de la Nación. Propósitos, nuevos criterios de inclusión y recomendaciones para su administración Vacunación en huéspedes especiales. Lineamientos Técnicos. Actualización Argentina 2014
- Sociedad Argentina de Pediatría. Actualización sobre vacunas: recomendaciones de 2018. Arch Argent Pediatr 2019;117 Supl 2:S37-S119



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **J**

EXAMEN NEUROLÓGICO EN PEDIATRÍA

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría



Dr. Jorge Larcamon

Jefe del Servicio

Dra. Paola Basualdo

Instructora de Residentes

Dra. Iara Chocron

Jefa de Residentes

Dra. Andrea Panozzo

Pediatra

Dra. María Belén Hunter

Dra. Soledad Ortiz López

Dra. María Agustina Parillo

Residentes

Dr. Walter Barbosa *

Revisor

Dra. Natalia Bayaut **

Revisora

Sumario

La riqueza de la buena evaluación neurológica del paciente logra un hecho fundamental en el ejercicio de la medicina. Situarnos en los órganos y sistemas posiblemente afectados para luego decidir pruebas de exámenes complementarios con mayor exactitud y así arribar al diagnóstico final. La importancia de la semiología en el camino al diagnóstico.

Situación clínica

Paciente de sexo masculino de 2 años de edad previamente sano que consulta a la guardia por presentar 12 hs de evolución de “debilidad” muscular simétrica que inicia en miembros inferiores con alteración de la marcha y progresa en forma ascendente hacia miembros superiores, impidiendo la deambulación.

Sin antecedentes perinatólogicos de importancia.

Antecedente de enfermedad actual: CVAS 3 semanas previas, autolimitado.

Examen físico: Paciente clínicamente estable, hemodinámicamente compensado, afebril. Exploración neurológica: estado de conciencia lúcido, vigil, reactivo, orientado en tiempo y espacio, pupilas isocóricas y reactivas.

Masa muscular normotrofica; Fuerza muscular disminuida en miembros inferiores grado 2 de escala de MRC y en miembros superiores grado 3 +; Tono muscular disminuido, presenta hipotonía generalizada a predominio de miembros inferiores con imposibilidad para la bipedestación; Reflejos osteotendinosos Tricipital, Bicipital, Supinación hiporreflécticos y Rotuliano, Aquileo arreflécticos; clonus y Babinski negativos.

Pares craneales; Agudeza visual conservada, Motilidad ocular conservada y sincrónica, pupilas simétricas y reactivas, acomodación y convergencia presentes. Motricidad y sensibilidad faciales conservados, reflejo maseterino presente; Fonación y deglución conservada; Movimientos palatinos simétricos. El reflejo nauseoso presente; Exploración neuromuscular cervical

y lingual conservada.

Sensibilidad superficial y profunda de difícil valoración en general conservada.

Abdomen, blando, depresible, no doloroso, RHA presentes; Sin globo vesical.

Reflexiones

¿Se puede a través de la anamnesis y examen físico neurológico identificar el tipo de lesión y su localización anatómica?

¿Se puede aproximar el diagnóstico etiológico?

A través de una anamnesis cuidadosa y un examen neurológico preciso se puede inferir el sitio anatómico y la fisiopatología de la lesión. De esta forma se reducen los diagnósticos diferenciales y exámenes complementarios.

Una vez que se ha identificado la localización de la lesión, se consideran las categorías etiológicas, que incluyen: Vascular, Infeccioso, Neoplásicos, Degenerativas, Traumáticas, Tóxicas metabólicas, Inmunomediadas.

Nota: Tener en cuenta cuando los signos y síntomas no se correlacionan con las reglas de la fisiología y anatomía acompañados de síntomas psiquiátricos puede deberse a un trastorno funcional psicógeno.

Enfoque diagnóstico

Evaluable al paciente de nuestro caso clínico con anamnesis y examen físico para luego seguir un esquema de pensamiento valorando: estado de conciencia, sistema motor, coordinación, evaluación de pares craneales y sensibilidad. Podemos identificar que el origen de la lesión se encuentra en la segunda motoneurona ya que presenta hipotonía, debilidad progresiva y simétrica en miembros inferiores con hiporreflexia osteotendinosa sin afectación de la conciencia, pares craneales y sensibilidad.

Dado el comienzo agudo, el antecedente infección viral se puede inferir que el diagnóstico es una parálisis flácida aguda.

ANAMNESIS:

Motivo de consulta

Se debe especificar cuál es el principal motivo de consulta.

Enfermedad actual

Determinar fehacientemente cuando ha sido el comienzo del cuadro.

Si hubo relación con algún suceso intercurrente

o desencadenante (traumatismo, enfermedad sistémica, infecciones, vacunación, fármacos).

Cuáles han sido los síntomas de inicio y cuáles se agregaron durante el transcurso de la enfermedad.

Cuál ha sido la evolución de cada uno de ellos (estática, progresiva, etc.).

Qué conductas se adoptaron durante este periodo y cuál fue la respuesta a las mismas.

Antecedentes personales y familiares.

Antecedentes personales: Interrogar por antecedentes durante la gestación, el parto y el periodo neonatal, la presencia de sucesos que hayan podido comprometer el flujo y la oxigenación cerebral.

Se recogerá, en detalle, la edad en que fue adquiriendo los hitos del desarrollo neuromadurativos.

Tanto lo madurativo como lo perinatal son marcadores de compromiso neurológico.

Antecedente de otras patologías.

Antecedentes familiares: estado de salud de los padres y los hermanos.

La presencia de signos que sugieran enfermedad hereditaria, y en algunos casos se realizará un familigrama para clarificar el patrón de herencia.

EXAMEN FÍSICO

El examen físico debe ser completo, minucioso, detallado y exhaustivo. Evitar focalizarse en las orientaciones diagnósticas para no sesgar la interpretación.

Es importante conseguir la colaboración del niño, que se sienta cómodo y seguro. Todo contacto tiene que ser suave. El ambiente debe ser cálido y agradable.

La observación de la postura y los movimientos del niño puede proporcionar información valiosa.

Las primeras maniobras serán en forma de juegos. Pudiendo de esta forma evaluar la marcha, movimientos oculares, destreza manual, coordinación, etc.

El comportamiento mientras interactúa con sus padres, aporta datos de significación. Por ejemplo en caso de ser impulsivo puede tratarse de un trastorno por déficit de atención / hiperactividad o una desconexión con el medio que lo rodea, en un niño con discapacidad neurológica.

Las maniobras más molestas o invasivas deben reservarse para el final.

La exploración neurológica debe ser sistemática. Es importante seguir siempre el mismo esquema y mantenerlo, con adaptaciones según la edad y grado de maduración.

Proponemos una sistematización que incluye, las maniobras más importantes para realizar una exploración neurológica en el ámbito de la Pediatría General.

- ✓ ESTADO DE CONCIENCIA
- ✓ SISTEMA MOTOR
- ✓ MARCHA, POSTURA Y COORDINACIÓN
- ✓ PARES CRANEALES
- ✓ SENSIBILIDAD

ESTADO DE CONCIENCIA

Se entiende por estado de conciencia, el grado de percepción de sí mismo y el entorno. Lo que permite evaluar la actividad de las funciones neurocognitivas.

Para evaluar el estado de alerta podemos utilizar la siguiente escala de Glasgow:

Se debe sumar los puntajes obtenidos de los 3 bloques que conforman la prueba para obtener el puntaje total.

Un estado de alerta disminuido puede progresar, por tal motivo es importante su continua

evaluación.

Ante alguna modificación debe descartarse: traumatismo craneoencefálico, afecciones metabólicas, alteraciones hidro-electrolíticas.

SISTEMA MOTOR

En la vía piramidal las señales motoras se transmiten directamente desde la corteza hasta la medula a través del fascículo cortico-espinal e Indirectamente por múltiples vías accesorias.

Se origina en los dos tercios superiores del área motora de la corteza cerebral, Terminando en los núcleos de las astas anteriores de la medula espinal. Su última neurona es la vía motora final común.

El 80 % de las fibras del fascículo se decusan a nivel de las pirámides del bulbo, formando el haz corticoespinal lateral, el cual se encargará de la musculatura distal de las extremidades.

Por esta razón, si se produce una lesión por encima del nivel de la decusación motora las manifestaciones clínicas se observan contralateral al sitio de lesión. Por el contrario, si la lesión es por

APERTURA OCULAR		
Espontánea		4
Reacción al hablar		3
Reacción al dolor		2
No hay respuesta		1
RESPUESTA MOTORA		
Espontánea (o sigue órdenes verbales)		6
Localiza el dolor		5
Retira en respuesta al dolor		4
Flexión anormal en respuesta al dolor (postura de decorticación)		3
Extensión anormal en respuesta al dolor (postura de descerebración)		2
No respuesta		1
RESPUESTA VERBAL		
Sonríe, orientado hacia el sonido, seguimiento de objetos, interactúa		5
LLANTO INTERACCIÓN		
Consolable	Inconsolable	4
Consolable de forma inconsciente	Gemido	3
Inconsolable	Irritable	2
Sin respuesta	Sin respuesta	1
NORMAL		Mayor o igual a 13 puntos
ANORMAL		Menor de 13 puntos

debajo de la decusación, la manifestación será ipsilateral al sitio de lesión.

Las fibras que no se decusan continúan como haz corticoespinal anterior, encargándose de la musculatura axial.

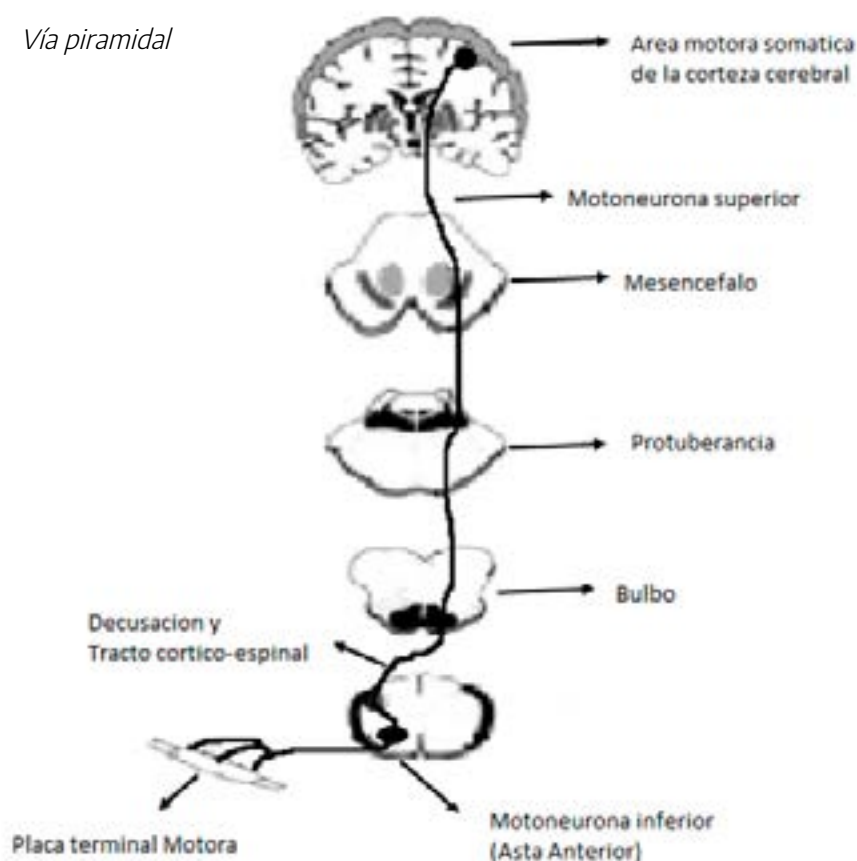
El sistema piramidal actúa inhibiendo o facilitando la acción de la motoneurona que se encuentra a nivel de la médula espinal. Por lo tanto, realiza control de todos los movimientos voluntarios a través de un proceso de inhibición de motoneuronas, o a través de un proceso de estimulación de estas. Esto explica por qué cuando hay una lesión de motoneurona superior en una primera instancia se produce una parálisis espástica, debido a que se libera la motoneurona inferior del control de la superior.

La vía extrapiramidal está formado por regiones de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales que descienden desde el encéfalo a la médula espinal donde inervan a las motoneuronas alfa. Su función es mantener la postura y equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios, controlar movimientos involuntarios y mantener el tono muscular.

En base del examen físico podemos diferenciar si la lesión se encuentra en la motoneurona su-

SIGNO	MOTONEURONA SUPERIOR	MOTONEURONA INFERIOR
Reflejos miotáticos ("tendinosos")	Hiperreflexia	Hiporreflexia
Clonus (p. ej. Clonus aquiliano)	Presentes	Ausente
Reflejos patológicos	Presentes (signo de Babinski, signo de Rossolimo)	Ausentes
Atrofia muscular	Ausente; puede desarrollarse atrofia secundaria a la inactividad (desuso de los músculos paréticos o paralizados)	Presente. Marcada
Tono muscular	Aumentado (espasticidad)	Disminuido (hipotonía)
Síncinesias patológicas	Presentes	Ausentes
Fasciculaciones	Ausentes	Presentes

Vía piramidal



perior o inferior.

Exploración motora

La exploración motora incluye la valoración de la fuerza, tono y reflejos de estiramiento muscular.

Fuerza muscular

Es la capacidad de un músculo o un grupo de ellos de contraerse ante una carga. Se explora realizando maniobras de oposición a los movimientos.

Solicite que realice movimientos de las distintas partes del cuerpo, mientras observa en forma espontánea su amplitud, velocidad y resistencia (ante la gravedad y la oposición del explorador). Vea la escala MRC (Medical Research Council) para graduar la fuerza.

La alteración en la fuerza se puede manifestar como disminución (paresia) o pérdida de la misma (plejía).

En lesiones hemimedulares, la afectación del hemicuerpo es ipsilateral a la lesión medular.

En el caso de lesión medular completa, si es superior a C5 la afectación se produce en las 4 extremidades (tetraparesia/plejía), por debajo de dicho nivel esta se produce en las extremidades inferiores (paraparesia/plejía).

Escala de fuerza muscular modificada del MRC

Grado 5	Fuerza muscular normal contra resistencia completa
Grado 4 +	Movimiento activo completo contra gravedad y contra resistencia completa
Grado 4 -	Movimiento activo completo contra gravedad y contra resistencia mínima
Grado 3 +	Movimiento activo que solo puede realizarse de forma completa contra la gravedad
Grado 3 -	Movimiento activo que solo puede realizarse de forma parcial contra la gravedad
Grado 2	Movimiento activo que no puede vencer la fuerza de gravedad
Grado 1	Mínima contracción muscular visible sin movimiento
Grado 0	Ausencia de contracción muscular: parálisis

Respuesta normal: adecuada ejecución del movimiento y fuerza grado 5 en todos segmentos del cuerpo.

Respuesta Anormal: Inadecuada ejecución del movimiento y/o fuerza grado 4 o < 4 en algunos o todos los segmentos del cuerpo.

Los lactantes y niños que no pueden colaborar se pueden evaluar mediante las maniobras de juego, como por ejemplo, en extremidades superiores haciendo que alce un objeto sobre la cabeza o manipulando objetos. En <2 meses, es posible utilizar el reflejo de agarre palmar para evaluar la fuerza distal y el de Moro para fuerza proximal.

Ante una disminución de la fuerza en las extremidades inferiores se observa disminución de la actividad espontánea e incapacidad de soportar su peso corporal en posición vertical. Siendo mayores se observa afectación al escalar o saltar.

Las maniobras clásicas para examinar la fuerza de diferentes grupos musculares son:

- Maniobra de Gowers: se indica que pase de la posición de decúbito supino a la de bipedestación. Los niños con miopatías primero giran a prono y luego se enderezan apoyándose en las rodillas («trepan por las rodillas»).
- Maniobra de Barré de extremidades superiores: se indica que ponga sus brazos en horizontal, con las palmas hacia arriba y mantenga dicha postura. Si existe pérdida de fuerza, caerá uno u ambos brazos.
- Maniobra de Manganizzi: explora la fuerza de las extremidades inferiores. Partiendo de una posición de decúbito supino se le pide que flexione los muslos sobre la pelvis y mantenga las piernas elevadas horizontalmente. Ante la presencia de una debilidad muscular se debe valorar si es aguda o crónica, generalizada o localizada, de predominio proximal o distal, y si se asocia o no a atrofia muscular.

Tono muscular

El tono muscular es, una contracción muscular inconsciente, continua y parcial, que crea resistencia al movimiento pasivo de una articulación.

Se explora por medio de la inspección, la palpación y las pruebas de motilidad pasiva. En se-

destación, flexione y extienda las articulaciones de los miembros superiores e inferiores. Se debe valorar la amplitud de los movimientos pasivos en relación a la resistencia al desplazamiento.

Las alteraciones del tono muscular pueden ser por aumento, rigidez y espasticidad, o por disminución, hipotonía.

La espasticidad se presenta como una resistencia inicial al movimiento pasivo, seguida de una liberación repentina (fenómeno de la navaja). Está originada en una disfunción de la neurona motora superior, con afectación preponderantemente flexora en los brazos y extensoras en los miembros inferiores. Se asocia a hiperreflexia y Babinski.

En los lactantes, la espasticidad de los miembros inferiores se observa como postura de tijera al ser suspendido en forma vertical. En los niños mayores al caminar en puntas de pie.

También se pueden presentar opistótonos, que es la hiperextensión severa por contracción muscular paraespinal.

La hipotonía del lactante es expresión habitual de afectación neurológica a distintos niveles, desde central a periférica. Evidencia aumento de la flexibilidad, adoptando postura en ancas de rana en decúbito.

ARCOS REFLEJOS

Son respuestas motrices involuntarias a estí-

mulos sensitivos. Hay dos tipos: los osteotendinosos y los cutáneos.

Reflejos osteotendinosos

Los reflejos osteotendinosos son la respuesta muscular de contracción tras la percusión del tendón correspondiente. El órgano receptor se encuentra en un tendón concreto, el cuerpo neuronal aferente en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal, que hace sinapsis con la neurona eferente motora y esta con el órgano efector muscular. Puede existir una alteración del mismo ante una lesión en cualquiera de sus niveles.

Evaluación: utilizando el martillo de exploración neurológica de un golpe breve y seco sobre el tendón elegido, ya sea directamente o bien sobre un dedo del explorador apoyado sobre el tendón.

Reflejos de estiramiento muscular más frecuentemente explorados

Reflejos osteotendinosos: Valoración clínica

La respuesta puede evaluarse como: arreflexia, hiporreflexia, normorreflexia e hiperreflexia.

Ante la falta de respuesta es importante destacar si la maniobra fue practicada en forma adecuada.

Una disminución de la respuesta cuando es

REFLEJO	TENDÓN EXPLORADO	ACCIÓN ESPERADA	NERVIO EXPLORADO	RAÍCES NERVIOSAS EXPLORADAS
Tricipital	Tendón del tríceps	Extensión del codo	Radial	C6,C7,C8
Bicipital	Tendón del bíceps	Flexión del codo	Musculocutáneo	C5,C6
Supinación	Extremo distal del radio	Flexión del codo y dedos	Radial	C6,C7
Rotuliano	Tendón rotuliano	Contracción del cuádriceps	Femoral	L2,L3,L4
Aquileo	Tendón aquileo	Contracción de los músculos de la pantorrilla	Tibial	S1,S2

generalizada y no se acompaña por otras anomalías neurológicas carece de valor patológico.

La asimetría tiene mayor significado patológico que el tipo de respuesta, si ésta es generalizada.

Hiperreflexia va desde ligera hasta el policinetismo (Contracciones repetidas, debidas a la autoalimentación del reflejo).

Características:

1. Viveza, brusquedad y amplitud excesiva. En algunos casos, el simple contacto del martillo provoca una respuesta inmediata.

2. Aumento del área de obtención del reflejo.

3. Difusión de la respuesta a músculos o grupos musculares por lo habitual no implicados en ella. En lactantes es normal, en adultos debería considerarse anormal.

Clonus: Es una respuesta patológica, en la que, a partir del estiramiento brusco y sostenido de un músculo este responde con contracciones rítmicas y reiteradas.

Reflejos mucocutáneos

Los reflejos cutáneos son producidos por estimulación de la piel o de las mucosas.

Reflejo corneano. El contacto de una torunda de algodón con la córnea provoca el cierre de los párpados. Evalúa la vía sensitiva de la rama oftálmica del trigémino (V par) y la motriz del facial (VII par).

Reflejos abdominales. Se exploran con el paciente en decúbito supino procurando que la musculatura abdominal esté relajada. Utilizar objeto punzante, Se estimula rozando la piel del abdomen desde los bordes hacia la línea media. El estímulo no debe ser doloroso. Consisten en la contracción de los músculos abdominales homolaterales con desviación de la línea alba y el ombligo hacia el área estimulada.

Reflejo cremasteriano. En la misma postura que el previo y utilizando un explorador pun-

zante, se roza la piel observándose la elevación del testículo dentro de las bolsas. Existe tres niveles: Superior (epigástrico), medio (umbilical) y la porción superointerna del muslo.

Reflejo anal. El pinchazo mucosa en la región perianal provoca la contracción del esfínter externo.

Reflejo plantar y signo de Babinski: Se realiza en decúbito supino con la pierna extendida mediante el roce con un objeto duro en la planta del pie. Partiendo del talón, se debe seguir el borde externo del pie y continuar sobre las articulaciones tarsofalángicas. La respuesta normal es flexión plantar de los dedos. Esta puede abolirse si el pie está frío o la rodilla flexionada.

En caso de afectación de la vía piramidal se provoca el signo de Babinski que consiste en una respuesta de dorsiflexión marcada del dedo gordo y separación de los restantes.

Sucedáneos de Babinski: Igual respuesta que el signo de Babinsky.

Reflejo Oppenheim: Deslizando los nudillos a lo largo de la tibia anterior.

Reflejo Gordon: Compresión de los gemelos o músculos flexores profundos de la pantorrilla.

Reflejo Rossolimo: Por percusión con martillo de la superficie plantar del primer dedo del pie.

Reflejo Schaffer: Se pellizca el tendón de Aquiles, tercio medio, unos segundos.

Reflejo Chaddock: Estimulando por debajo del maléolo externo del pie.

Reflejos cutáneomucosos: Valoración clínica de:

Los reflejos cutáneos tienen un arco medular semejante al de los profundo y un segundo arco que alcanza la corteza. Este largo trayecto los hace muy vulnerables a las lesiones medulares. Su ausencia ante la exacerbación de los ROT es signo de afectación piramidal.

Su presencia con abolición de los restantes señala el nivel de afectación medular.

EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y MARCHA

Exploración del cerebelo:

El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las ór-

REFLEJO MUSCULOCUTÁNEO	NIVEL MEDULAR
CORNEANO	V Y VII PAR
ADOMINALES	SUPERIOR:D6-D9 MEDIO:D9-D11 INFERIOR:D11-L1
CREMASTERIANO	L1-L2
PLANTAR	S1-S2

denes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras.

Para estudiar su funcionamiento y del sistema del equilibrio, se han de realizar una serie de maniobras que requieren la colaboración del paciente, lo que hace que su correcta evaluación sea complicada en nuestros pacientes más jóvenes:

- Marcha en tándem: se pide al paciente que ande pisando una línea apoyando el pie de tal manera que el talón del pie de avance contacte con los dedos del pie más retrasado. En los pacientes con alteraciones leves del equilibrio, aparece la inestabilidad. Una afectación grave del cerebelo muestra inestabilidad en la marcha normal o en la bipedestación.

- Test de Romberg: compara el grado de inestabilidad del paciente en bipedestación con los pies juntos entre una situación con los ojos abiertos y una situación con los ojos cerrados. Los pacientes con afectación cerebelosa tienen inestabilidad en ambas situaciones, mientras que los pacientes con afectación vestibular o sensitiva empeoran su inestabilidad con los ojos cerrados.

- Prueba dedo-nariz: es un método para medir dismetría y, sobre todo, temblor intencional. Es importante insistir al niño en que no es una prueba de velocidad sino de precisión. En pacientes que no colaboren en la prueba o si se quiere registrar fácilmente en la historia el grado de alteración, se les puede pedir que copien una espiral.

- Prueba dedo-dedo: consiste en que el paciente siga el dedo del explorador que cambia de posición cuando el paciente lo alcanza. Es un método para medir la dismetría.

- Movimientos rápidos alternantes de las manos: se pide al paciente que realice alternativamente movimientos de pronación y supinación sobre su muslo tan rápido y preciso como pueda. Es un método para evaluar la disdiacokinesia. Se puede afectar también por distonía, espasticidad o en pacientes con dispraxias.

- Prueba de talón-rodilla: en decúbito supino, se pide al paciente que toque con el talón la rodilla contralateral y que baje tocando la espinilla. Evalúa la dismetría y el temblor en miembros inferiores

Las alteraciones de la marcha característicamente se han descrito con base en el tipo de marcha:

- a) Marcha parética: se caracteriza por levantamiento exagerado de la pierna a cada paso,

mientras el pie cuelga, apoyándose en su punta.

- b) Marcha hemipléjica la pierna de lado afectado cruza delante de la otra trazando un semicírculo arrastrando el pie que apoya sobre el suelo por su borde externo y punta. Marcha característica de las lesiones de un hemisferio cerebral.

- c) Marcha atáxica: ambas extremidades están afectadas, hay un aumento en la base de sustentación, inestabilidad, brazos extendidos, cabeza oscilante y zigzagueo de derecha a izquierda. Marcha característica de lesiones en los cordones posteriores o lesiones cerebelosas.

Causas de ataxia aguda en edad pediátrica: Intoxicación, infección del SNC, postinfecciosa o de base inmunológica, traumatismos encefalocraneanos, tumores de fosa posterior, patología cerebrovascular, enfermedades hereditarias, reacción psicógena.

PARES CRANEALES

Son nervios que se originan y están en comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base del cráneo para inervar distintas estructuras. Son doce pares enumerados en números romanos según el orden y localización anatómica: intracerebrales (I y II par) mesencéfalo (III y IV) protuberancia (V, VI, VII, VIII) bulbo (IX, X, XI, XII)

Se los puede clasificar fisiológicamente en:

Nervios sensitivos/sensoriales: I, II y VIII

Nervios motores: III, IV, VI; XI y XII

Nervios mixtos: V, VII; IX y X

Par Craneal, Nervio olfatorio: La exploración se realiza empleando sustancias de olor familiar y no irritante: chocolate, alcohol, perfumes, etc. Los trastornos pueden ser por aumento, disminución o abolición (anosmia) de la percepción de los olores. Causado por traumas de cráneo, lesiones del lóbulo frontal, meningioma del tracto olfatorio o lesiones nasales.

Par Craneal, Nervio Óptico: Se explora a través de: agudeza visual, visión grosera en los más pequeños y tablas de la letra E o de figuras en los mayores de 4 años. Campo visual, se evalúa moviendo los dedos o un juguete del área temporal a nasal, la prueba se hace comparativa y con la mirada fija en el examinador. El conteo de dedos también puede utilizarse. Por último evaluar con fondo de ojo, práctica que el pediatra debiera familiarizarse más.

Par Craneal, Nervio Motor Ocular Común: Inerva músculos extraoculares, como el recto interno, recto superior y oblicuo inferior. Inervación del esfínter pupilar, el elevador del párpado y el músculo del cuerpo ciliar. Por lo tanto su lesión provoca: Ptosis palpebral, desviación del ojo hacia abajo y afuera y midriasis pupilar-

Par Craneal, Patético: Inerva músculo oblicuo superior, por lo tanto su lesión provoca imposibilidad de llevar el ojo hacia abajo y adentro.

VI: Par Craneal, Motor ocular Externo: Inerva al músculo recto externo y su lesión provoca desviación del ojo hacia adentro e imposibilidad de llevarlo hacia afuera.

Par Craneal, Trigémino: Nervio mixto con función motora, inerva los músculos de la masticación y sensitiva, ramas: oftálmica, maxilar superior y mandibular. Se encuentra afectado frecuentemente en las fracturas de cráneo, la rama motriz inerva masetero, temporal y pterigoideos y su lesión hace que se desvíe hacia el lado afectado. La rama sensitiva le da la sensibilidad a la cara en sus distintas porciones y los reflejos que comanda son el corneal y el maseterino.

Par craneal Facial: es el más frecuentemente lesionado, bien a nivel central o en su recorrido periférico. Se explora observando la expresión facial espontánea (asimetrías en la apertura palpebral, la comisura bucal, o en los surcos nasogenianos). La rama superior se explora pidiendo al paciente que eleve las cejas, cierre los ojos y frunza la frente. La inferior, pidiéndole que sople, que infle las mejillas, que sonría. La rama sensitiva recoge el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.

Par craneal Vestibulo-coclear: Con la prueba de Weber se valora ésta última; para ello se aplica el diapasón sobre el cráneo, en un punto equidistante de ambos oídos. Si existe lesión unilateral del oído interno ocurrirá lateralización de la prueba hacia el oído sano (la cóclea normal será estimulada con mayor intensidad), en tanto que cuando la lesión asienta en el oído externo o medio la lateralización será hacia el lado enfermo. Otra prueba es la de Rinne; con esta se compara la transmisión del sonido por vía aérea y ósea, colocando de forma alternativa el diapasón en la apófisis mastoides y luego frente al pabellón auditivo. En condiciones normales la percepción será mayor y más prolon-

gada por vía aérea: Rinne positivo (tras dejar de oírlo en la mastoide continuará escuchándolo por vía aérea); lo mismo ocurre cuando existe lesión en el oído interno. Sin embargo cuando la lesión asienta en el conducto auditivo externo o en el oído medio la prueba será negativa, siendo en estos casos la transmisión ósea superior a la aérea.

IX y X. Par craneal Glossofaríngeo y vago: el componente motor de estos nervios tiene a su cargo los músculos que intervienen en la deglución y la fonación respectivamente.

Par craneal Espinal: inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Se explora comprobando la contracción del primero al girar la cabeza, y pidiendo al niño que levante los hombros.

Par craneal Hipoglosa: se explora pidiendo que saque la lengua y la mueva en todas las direcciones. En la parálisis unilateral la lengua al sacarla se desvía hacia el lado afecto.

SENSIBILIDAD

Se denomina sensibilidad a la percepción de estímulos originados en el propio individuo o en el entorno.

La evaluación de la sensibilidad requiere condiciones adecuadas. El niño debe estar consciente y colaborador, con los ojos cerrados.

Para la exploración de este apartado es fundamental realizar la evaluación de forma comparativa, además de evaluar los diferentes dermatomas.

El examen comprende la exploración de la sensibilidad superficial y profunda.

La sensibilidad superficial incluye la táctil, térmica y dolorosa.

Para evaluar la sensibilidad táctil, tome un trozo de algodón y vaya tocando suavemente distintos puntos de la piel debiendo indicar el niño cada vez que sienta el estímulo.

Evalúe la sensibilidad térmica con un objeto frío y otro caliente y vaya tocando suavemente distintos puntos de la piel debiéndole indicar el niño cuando sienta el estímulo caliente o frío.

La sensibilidad dolorosa se puede evaluar con un objeto punzante. Vaya tocando suavemente distintos puntos de la piel debiéndole indicar el niño qué se pincha cuando sienta el estímulo. ("toco - pincho")

Evaluación de la sensibilidad profunda: sensibilidad vibratoria y propioceptiva.

Se evalúa la percepción de la vibración colocando un diapasón sobre las superficies óseas de codos, muñecas, rodillas y tobillos. Valore la presencia y simetría de la percepción de Vibración.

ANÁLISIS DEL CASO PRESENTADO:

En primer lugar como dato a destacar entre la atípica presentación del cuadro clínico descripto y la riqueza de la descripción semiológica queda demostrado como la buena evaluación del paciente logra un hecho fundamental en el ejercicio de la medicina situarnos en los órganos y sistemas posiblemente afectados para luego decidir pruebas de exámenes complementarios con mayor exactitud y así arribar al diagnóstico final.

En segundo lugar un hecho destacable es la definición de una entidad que nos obliga a estar atentos a la evolución del paciente en lo inmediato y tal vez su denuncia epidemiológica.

Valor de la descripción semiológica y probables hipótesis diagnósticas:

Nos sitúa en un tipo de parálisis, en este caso, flácida y ascendente. Esta contundente definición nos obliga a la evaluación respiratoria por potencial necesidad de ARM. Además de la denuncia epidemiológica por posible afectación de enterovirus y descartar la aparición de un caso de poliomyelitis.

Si bien el caso es atípico la riqueza de los datos obtenidos logra la contundencia de situarnos en una enfermedad del SNC (médula espinal) y SNP, la presencia de clonus y Babinsky son signos de compromiso del haz piramidal evidenciando lesión medular al no tener el paciente ningún signo de déficit encefálico y la arreflexia con hipotonía nos ubican en el SNP o en la fase

flácida del shock medular. Por último la falta de afectación vesical no termina de cerrar la posibilidad concreta de afectación medular.

Para finalizar lo interesante de la descripción es: saber qué debemos explorar (SNC y SNP) y las hipótesis diagnósticas serían Guillain Barré atípico, variantes de la mielitis transversa clásica y la afectación vascular medular por isquemia (más raro en esta edad) o por sangrado de una MAV.

Por último, este valioso examen clínico nos lleva a la conclusión que con una punción lumbar, un estudio de velocidad de conducción nerviosa más un electromiograma y por último una evaluación de neuroimágenes nos darían la información necesaria para arribar a un diagnóstico y correcto tratamiento.

Bibliografía

- Fejerman N, E. Fernández Álvarez. *Neurología Pediátrica* 3ª edición. Panamericana 2011
Fiz Pérez, I, Pulido, D. G. (2015). *Exploración neurológica por el pediatra de AP. Pediatría Integral*, XIX(8), 1-7.
Gómez H. (2013). *Manual de Exploración Neurológica para Niños Menores de Cinco Años en el Primer y Segundo Nivel de Atención*.
Kliegman R, R. Behrman, H. Jenson, B. Stanton. *Nelson Tratado de Pediatría*. 18ª edición. Editorial Elsevier 2009
López, M. V. S. (2009). *Examen neurológico del niño. Formación Activa En Pediatría de Prevención Primaria.*, 2(1), 50-54.

Dr. Walter Barbosa Revisor

Especialista en Neurología infantil del Hospital El Cruce
Néstor Carlos Kirchner.

****Dra. Natalia Bayaut Revisora****

Especialista en Neurología infantil del Hospital El Cruce
Néstor Carlos Kirchner.

CEFALEAS EN PEDIATRÍA

Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela.
Residencia de Clínica Pediátrica



Dra. Cecilia M. Santolín

Instructora de Residentes

Dra. Natalin Grassi Llofriu

Jefa de Residentes

Dr. Martín Amigucci

Dr. Walter Barbosa*

Revisor

Sumario

Cefalea es el dolor o malestar referido a la cabeza, originado en estructuras craneales o bien irradiado a las mismas. Constituye un trastorno infra diagnosticado e infra tratado en Pediatría. Puede ser una manifestación habitual de enfermedades infecciosas, procesos sistémicos, del SNC o constituir una entidad con identidad propia como la migraña. Asociada a una elevada carga de ansiedad familiar y personal, representa, junto con los trastornos en el aprendizaje, uno de los motivos de consulta más frecuente en Neurología infantil.

Caso clínico

Sofía de 11 años ingresa por guardia por cefalea frontal opresiva de intensidad ascendente de 3 días de evolución, con vómitos y fotofobia en las últimas 6 horas. Sin otro signo y/o síntoma, se le suministraron analgésicos en el hogar con escasa respuesta por lo que consultan. A su ingreso se realiza TAC de cerebro de características normales, por lo que se indica di-

pirona y dexametasona endovenosa, dejándose en observación, presenta primer registro febril (38.1°C) por lo que se decide realizar punción lumbar, obteniéndose líquido cefalorraquídeo (LCR) de características cito físico químicas normales. Se envía muestra para cultivo y virológico. Continuando bajo control clínico. Con buena evolución con post punción. Con cultivos y virológico negativos.

Dante de 9 años, es el hermano de Sofía. Al segundo día de observación de su hermana, concurre traído por su madre por cefalea occipital con vómitos de 12 horas de evolución, sin registros febriles ni otros signos ni síntomas asociados, con TAC normal, se indican analgésicos endovenosos con escasa respuesta. Se interroga sobre alteraciones vinculares familiares, o conflictos de nueva data que podrían estar involucrados en la génesis de estos cuadros, pero los padres niegan dicha posibilidad, descartándose también antecedentes de migraña familiar.

Se realiza por evolución punción lumbar obteniéndose líquido cefalorraquídeo cito fisicoquímico ligeramente turbio, con presencia de abun-

dantes hematíes, 120 elementos con predominio de PMN, química normal. Cultivo negativo, virológico positivo para Virus Epstein Barr (VEB). Con IgM positiva para VCA VEB en ambos niños.

La infección por VEB afecta a cerca del 90% de las personas en la primera década de la vida. Puede tratarse de una infección asintomática, cursar como una mononucleosis infecciosa, y rara vez causa afectación del SNC, siendo primordialmente en pacientes inmunodeprimidos. Las encefalitis por VEB no difiere de otras virales en su presentación clínica. Se diagnostica por PCR en LCR con serología compatible en sangre. No contándose con tratamiento específico para la misma, suele ser de evolución benigna. (10)

Introducción

Se define cefalea como el dolor o malestar referido a la cabeza, originado en estructuras craneales o bien irradiado a las mismas. Constituye un trastorno infra diagnosticado e infra tratado en Pediatría. Puede ser una manifestación habitual de enfermedades infecciosas, procesos sistémicos, del SNC o constituir una entidad con identidad propia como la migraña. Asociada a una elevada carga de ansiedad familiar y personal, representa, junto con los trastornos en el aprendizaje, uno de los motivos de consulta más frecuente en Neurología infantil.

Puede presentarse a cualquier edad, aumentando su incidencia durante la adolescencia. A los 7 años, su prevalencia oscila entre 37 a 82%. Antes de la pubertad predomina en varones, posteriormente en niñas. Cuando el síntoma se presenta reiteradamente o su intensidad es severa interfiere en la vida diaria familiar, constituyendo una de las causas más frecuentes de ausentismo escolar, si se tiene en cuenta que a la edad de 14 años el 96 % de los niños han padecido algún episodio de cefalea. Es por eso que la consulta de un niño con cefalea implica, para los padres descartar enfermedad grave, mientras que los niños buscan el alivio del dolor.

La frecuencia de la cefalea aumenta con la edad, alcanzando un pico de prevalencia a los 11-13 años en ambos sexos. Las cifras de prevalencia varían en función de localizaciones geográficas. Un meta análisis realizado en Estados Unidos muestra, en una población de 27000 niños, que antes de los 7 años un 37-51% había presentado episodios de cefalea recurrente, alcanzando cifras de hasta el 57-82% a la edad de 15 años. Otros estudios estiman una prevalencia de cefaleas en niños y adolescentes de hasta 20 años de edad de un 58%, con una ratio mujer/varón de 1,5/1. (4,7,9)

Cefaleas Agudas	Cefaleas Agudas Recurrentes	Cefaleas Crónicas
Frecuentes	Frecuentes	Abuso de analgésicos
Infección sistémica.	Migraña	Hematoma subdural
Sinusopatía aguda	Cefalea tensional episódica	Tumor cerebral
Meningitis	Raras	Absceso cerebral
Síndrome postraumático	Hidrocefalia intermitente	Pseudotumor de cerebro
Primera crisis de migraña	Feocromocitoma	Estado migrañoso
Cefalea secundaria a punción lumbar	Cefalea desencadenada por la tos	Cefalea tensional crónica
Raras	Cefalea punzante idiopática	
Encefalitis	Cefalea agrupada o en racimos	
Hemorragia subaracnoidea	Hemicránea crónica paroxística	
Hematoma subdural	Neuralgia del trigémino	
Hematoma epidural	Cefalea benigna desencadenada por el ejercicio	
Glaucoma	Colapso ventricular por válvula hiperfuncionante	
Neuritis óptica	Cefalea relacionada con el síndrome de apnea obstructiva del sueño	

Tabla 1. Clasificación de cefaleas infantiles según patrón temporal. Sus causas (8)

Clasificación

Desde un punto de vista clínico parece más manejable la clasificación de Rothner de 1983, que diferencia las cefaleas en función de su evolución cronológica en:

- Agudas. Cefaleas de una duración inferior a 5 días y sin antecedentes de cefaleas previas.
- Agudas recurrentes. Crisis de cefalea que recurren periódicamente, con intervalos libres de síntomas.
- Crónicas no progresivas. Cefaleas que duran más de 15-30 días con frecuencia e intensidad de los episodios similares, estables, con ausencia de signos neurológicos anormales. (9)

Prevalencia según la etiología: (4)

- ✓ Cefaleas asociadas a infecciones: 30%
- ✓ Cefaleas de tipo tensional: 29 %
- ✓ Migraña: 21 %
- ✓ Cefalea idiopática: 14 %
- ✓ Lesión ocupante de espacio: 4%

Descripción de los cuadros más frecuentes

Migraña: es la causa más frecuente de cefalea aguda recurrente en la infancia y la adolescencia. Consiste en ataques recurrentes de dolor de cabeza de frecuencia e intensidad variable, de localización unilateral usualmente asociada a náuseas y vómitos. Afecta al 4-8 % de los niños entre los 7 y 15 años. Tiene una base hereditaria, se agrava con la actividad física e interfiere con la vida habitual. Como complicaciones pueden sucederse infarto cerebral o estado de mal migrañoso.

Según la International Headache Society existen criterios diagnósticos (ver tabla 2 y 3).

Cefalea tensional: trastorno frecuente del niño en la edad escolar. Definida como funcional o psicógena. Los episodios pueden durar desde minutos a días, se trata de un dolor opresivo de intensidad leve a moderada, bilateral, que no se acompaña de signos neurológicos focales ni síntomas digestivos, puede tener foto o fonofobia pero no ambas. Suele asociarse a factores emocionales, por lo que muchas veces se trata de un trastorno más profundo que es preciso explorar y descubrir (ver tabla 4).

Cefalea de origen oftalmológico: En relación

Al menos 5 episodios que cumplan los criterios B-C-D

B. Duración de los episodios entre 4 y 72 horas (sin tratamiento)

C. Cefalea con al menos dos de las siguientes características:

1. Localización hemicraneal
2. Calidad pulsátil
3. Intensidad moderada grave
4. Empeora con el ejercicio físico

D. Al menos uno de los siguientes durante la cefalea:

1. Náuseas, vómitos o ambos
2. Fotofobia o fonofobia

Tabla 2: Criterios diagnósticos de migraña sin aura (2)

Al menos dos episodios que cumplan el criterio B-C-D

B: al menos 3 de las 4 características siguientes: Uno o más síntomas de aura completamente reversibles que indique disfunción cerebral focal cortical, de tronco o ambas. Positivos (luzes, manchas) o negativos (pérdida de la visión). Por lo menos uno de los síntomas del aura se desarrolla gradualmente en más de 4 minutos, o dos o más síntomas del aura se desarrollan sucesivamente y ninguno dura más de 60 minutos.

La cefalea sigue al aura con un intervalo libre de menos de 60 minutos (puede comenzar antes o a la vez del aura).

Se agrava con la actividad diaria habitual.

C: al menos dos de los siguientes:

Síntomas visuales, sensitivos unilaterales o ambos.

Síntomas de aura que se desarrollan al menos 5 minutos o se suceden en ese tiempo.

Síntomas de aura que duran entre 5 y 60 minutos.

D: Cefalea que cumplen criterios B, C y D de migraña sin aura y que comience con aura o se presente dentro de los 60 minutos posteriores.

Tabla 3: Criterios diagnósticos de migraña con aura (2)

con esfuerzos visuales prolongados por lo que suelen ser vespertinas o nocturnas. Orbitarias o frontales acompañadas de molestias oculares y mejoran con el reposo. Resalta la importancia de la evaluación oftálmica periódica, de mane-

	Migraña	Cefalea Tensional
Localización	Uni o bilateral	Bilateral
Tipo de dolor	pulsátil u opresivo	opresivo
Frecuencia	intermitente	intermitente o continua
Cambios en el aspecto físico	frecuente	no
Foto y Fonofobia	frecuente	no
Náuseas y Vómitos	frecuente	no
Intensidad	moderada-grave	ligera-moderada
Síntomas Neurológicos	posibles	no
Aura	posibles	no
Antecedentes familiares	frecuentes	posible

Tabla 4: Diferencias entre migraña y Cefalea tensional en la infancia (2)

ra que se diagnostiquen precozmente trastornos de la agudeza visual (remitirse a capítulo de *Evaluación Oftalmológica en la Infancia – Pediatría en Red 2*).

Cefalea por lesión ocupante de espacio:

Por tumores: segunda neoplasia más frecuente en la infancia. Se asocia con el compromiso del estado general, cambios de carácter, cambios en el dolor, signos de foco neurológico o cuadro de hipertensión endocraneana.

Por hemorragia cerebral: secundario a traumatismos o a patología vascular congénita. Se trata de una cefalea de inicio súbito e intensidad severa con deterioro neurológico progresiva.

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

Una completa y detallada historia clínica es el elemento fundamental para llegar al diagnóstico de una cefalea. Se debe identificar si se trata de un cuadro primario o secundario, buscando signos y síntomas de alarma que sugieran estos últimos. De no encontrarse, se inicia el tratamiento interpretando el cuadro como primario.

ANAMNESIS: siendo detallada permite definir el diagnóstico en el 90 % de los casos. Considerando: Antecedentes familiares.

Antecedentes personales (cuadros previos, hábitos y conductas).

Características de la cefalea: localización, intensidad (se pueden utilizar las escalas de medición del dolor: numérica o escala facial de Wong Baker), tipo (opresiva, punzante, pulsátil), tiempo de evolución, periodicidad, síntomas acompañantes, horario de presentación.

FACTORES DESENCADENANTES: ansiedad, depresión, estrés, alimentos (cafeína, te, bebidas cola, chocolates, embutidos, enlatados, conservantes), ejercicio físico intenso, ayuno, tóxicos (tabaco, alcohol, drogas), frío, hipoglucemias, privación o exceso de sueño, menstruación.

Factores agravantes.

Factores atenuantes.

Tratamientos utilizados y su eficacia.

Se puede utilizar como herramienta la creación de un "diario de cefalea", donde el paciente detalle los datos antes mencionados de la manera más sencilla y práctica para cada caso (texto/gráficos). (5)

EXAMEN FÍSICO: debe ser completo al incluir tensión arterial, la auscultación intracraneal y el fondo de ojo, además de la exploración clínica neurológica específica.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: En caso de sospecha de procesos infecciosos se realizarán hemograma y clínica sanguínea. Considerar punción lumbar ante la presencia de hipertensión endocraneana y/o meningismo.

Se realizarán rayos x ante la sospecha de fracturas o patología de los senos paranasales.

El EEG es de escasa utilidad, pudiéndose ser útiles en el diagnóstico diferencial entre la migraña y la epilepsia.

Con respecto a la TAC y RNM, existen estudios que indican que son pocas las probabilidades de demostrar una lesión potencialmente tratable en niños con cefaleas crónicas, hallándose anomalías en aquellos que indagando retrospectivamente ya existía la sospecha por datos anamnésticos. (3)

Por lo tanto se sugieren neuroimágenes en casos de (3):

- ✓ Cefalea intensa de inicio agudo.
- ✓ Cefalea que interrumpa el sueño.
- ✓ Agravación aguda de una cefalea anteriormente crónica.
- ✓ Presencia de síntomas, signos o alteración del EEG de focalidad neurológica.
- ✓ Presencia de papiledema o rigidez de nuca o tortícolis o disminución de la agudeza visual.
- ✓ Presencia de fiebre, náuseas y vómitos no explicables por una enfermedad sistémica.
- ✓ Cefaleas no clasificables por la historia clínica o que no evolucionan o no responden a su tratamiento teórico.

Tratamiento

Una vez confirmado el diagnóstico, es necesario tranquilizar al paciente y la familia y explicar la naturaleza del trastorno así como informarles las diferentes alternativas terapéuticas disponibles para su caso.

El tratamiento deberá incluir medidas generales y medidas específicas.

Dentro de las medidas generales se aconsejarán un estilo de vida saludable: dieta equilibrada, descanso adecuado, manejo del estrés, organización de los horarios y tiempo libre.

Como medidas específicas se incluyen: evitar agentes precipitantes y tratamientos farmacológicos del síntoma y profilácticos.

En la fase aguda debe ser instalado el tratamiento farmacológico de manera inmediata utilizando paracetamol o ibuprofeno. Si se presenta vómitos pueden asociarse antieméticos como metoclopramida o domperidona.

En caso de estado mal migrañoso o estatus migrañoso se tratan con corticoides y fenitoina por vía endovenosa. La FDA sugiere en adultos el empleo de Sumatriptan oral, subcutáneo y spray nasal, pero aún no están probados en niños.

Puede utilizarse también en aquellos casos que se vea justificados (tres a cuatro episodios al mes al menos por tres meses) la incorporación de un tratamiento farmacológico profiláctico. Se trata de manejo frecuente hasta en un 25% de aquellos que consultan por migraña. Debe mantenerse por seis meses y luego iniciar la suspensión gradual. Las opciones terapéuticas son: Antihistamínicos-antiserotonérgicos. Bloqueantes betadrenérgicos (propanolol), prime-

ra elección en la prevención de migrañas sin aura. Bloqueantes de calcio.

Antidepresivos (amitriptilina dosis única nocturna). Neuromoduladores (topiramato, levetiracetam).

CRITERIOS DE INTERNACIÓN

- ✓ Cefalea intensa de inicio agudo.
- ✓ Síntomas o signos de focalidad neurológica o rigidez de nuca.
- ✓ Papiledema, hemorragias retinianas, tortícolis o disminución de la agudeza visual.
- ✓ Fiebre, náuseas y vómitos no explicables por una enfermedad sistémica.

CRITERIO DE DERIVACIÓN A NEUROPEDIATRA:

- ✓ Cefalea de etiología no aclarada.
- ✓ Cefalea crónica diaria.
- ✓ Síndrome HTE.
- ✓ Migraña refractaria.
- ✓ Cefalea tipo tensional refractaria.
- ✓ Disminución persistente agudeza visual.
- ✓ Signos de focalidad neurológica.
- ✓ Migraña hemipléjica familiar y esporádica.
- ✓ Sincope.

Referencias bibliográficas

1. Bravo, Gutiérrez, Maturana, Flores. Cefalea en niños; experiencia en un centro de referencia; Revista Chilena de Pediatría 2010; 81(5):409-417.
2. Quintana Prada; Cefaleas. Protocolos Diagnósticos y/o Terapéuticos de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP.
3. Romero Sánchez, Picazo Angelin, Tapia Ceballos, Romero González, Díaz Cabrera, Romero Sánchez; Efectividad de los estudios de neuroimagen en niños con cefalea. Anales Españoles de Pediatría 1998;49:487-490.
4. Lobera Gutiérrez de Pando, López Navarro, Youssef Fasheh, Vermet Bori. Luaces Cubells; Cefalea en una unidad de estancia corta. Anales Españoles de Pediatría 1999;50:562-565.
5. Polacov. Cefaleas en niños y adolescentes. PRONAP 2012; Capítulo 3; 69-88.
6. Binelli. Cefalea: Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría del Hospital Elizalde; Segunda Edición; Ediciones Journal; Capítulo 18.2; 386-391.
7. Di Blasí, Arroyo y Fejerman. Cefaleas y migrañas. Neurología Pediátrica; Tercera Edición; 48:675-690.
8. Campos Castello, San Antonio Arce. Cefalea en la infancia. Protocolos de Neurología de la Asociación Española de Pediatría, 2008.
9. Eiris Punal J. Cefaleas en la edad pediátrica. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2016. Madrid: Lua Ediciones 3.0; 2016. p. 113-28.
10. Peña Castellanos, Santana Porras; "Encefalitis severa por virus de Epstein Barr en paciente inmunocompetente: reporte de un caso."; Acta Neurol Colombiana.

*Dr. Walter Barbosa

Medico Neurólogo Infantil, Hospital SAMIC "El Cruce" de Florencia Varela.

EVENTOS PAROXÍSTICOS EPILÉPTICOS Y NO EPILÉPTICOS

ATAXIA

**Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien. Servicio de Pediatría.
Residencia de Clínica Pediátrica**



Dra. Mabel Kamuda

Jefa del Servicio de Pediatría

Dra. Soledad Cartasso

Instructora de Residentes

Dra. Eliana Pradejczuk

Jefa de Residentes

Dra. María de las Nieves Pereyra

Dr. Romel Camacho

Dra. Noelia Schreiner

Dr. Julio César Orcko Mamani

Dra. Mariana Tartabini

Dra. Lizet Oilos Ríos

Dra. Vilma Cardozo

Dra. Tatiana Alava

Dra. Magalí Lopreiato

Dra. Florencia Di Miro

Dra. Ana Pamela Martin

Dra. Melina Cobre

Dra. Carolina Virginia Rita

Dra. Jacqueline Pallotta

Dra. Florencia Garavagna

Dra. Shirley Gallardo

Dra. Marisol Buezo

Residentes

Dra. Eliana Julián*

Revisora

Sumario

Visión ampliada de eventos paroxísticos y de ataxia en pediatría.

Primera orientación para evaluar situaciones en distintos escenarios de la atención.

Situación clínica

Paula, de 13 años, ingresa a la guardia traída por su madre quien refiere que tuvo que retirar a su hija del colegio por haber presentado “un

desmayo”

Relata que estaba en el acto del colegio, hacía mucho calor y comenzó a “ver todo negro y sentía que caminaba entre algodones”, luego de esto no recuerda más nada.

Según la mamá, le informaron del colegio que el episodio tuvo segundos de duración, se encontraba pálida, sudorosa y al despertar se encontraba ubicada en tiempo y espacio.

Durante el episodio no presenta relajación de esfínter ni movimientos anormales.

Al examen clínico de ingreso se encuentra en buen estado general, lucida y orientada.

Presenta piel y mucosas de coloración normal, TA 110/70 mm FC 80lpm. Pulsos periféricos presentes y simétricos, la auscultación cardiopulmonar es normal. No se palpan visceromegalias en abdomen.

No toma ninguna medicación. No refiere antecedentes familiares de cardiopatía ni muerte súbita, sus abuelos son hipertensos. Ese día no había desayunado (habito común en ella)

Se realiza laboratorio de rutina que no muestra valores fuera de rango y se decide realizar un ECG de 12 derivaciones que muestra un ritmo normal.

Ante esta situación clínica nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales:

- ✓ Sincope vasovagal o cardiogénico
- ✓ Arritmia
- ✓ Disfunción miocárdica
- ✓ Epilepsia
- ✓ Migraña
- ✓ Causas tóxicas y metabólicas
- ✓ Origen psicógeno

EVENTOS PAROXÍSTICOS NO EPILÉPTICOS (TPNE)

Definición

Eventos neurológicos de origen brusco, recurrentes y breve duración. Se pueden manifestar de formas variadas (alteración del tono, de la postura, de los movimientos oculares, disminución del nivel de conciencia, alteraciones en el comportamiento, etc.).

Son originadas por una disfunción cerebral de origen diverso que tienen en común el carácter excluyente de no ser epilépticas, por lo cual no presentan expresión electroencefalográfica. Importante diferenciarlos de las crisis epilépticas ya que suelen ser benignas sin necesidad de tratamientos farmacológicos. 30% de niños con EPNE son tratados erróneamente como epilépticos.

El tratamiento dependerá de la etiología (tratamiento del reflujo en Síndrome de Sandifer o Higiene del sueño en los terrores nocturnos) siendo la mayoría benignos y autolimitados en el tiempo.

Epidemiología

Presentan una prevalencia en conjunto del 2%

en la población infantil. Son mucho más frecuentes que los episodios paroxísticos de tipo epiléptico (Relación 10:1).

Clasificación según etiología

- ✓ Crisis anóxicas
- ✓ Crisis psíquicas
- ✓ Trastornos motores paroxísticos
- ✓ Trastornos del sueño
- ✓ Otros: (Migrañas / VPBI/Vómitos cíclicos/ Tortícolis)

1. Crisis anóxicas - hipoxia cerebral

→ Espasmo del Sollozo:

- Prevalente entre los 6 meses a 3 años de vida. Pico de intensidad a los 2 años.
- Se presenta como episodio de apnea con fijación de la mirada, puede agregarse pérdida de la conciencia, rigidez, sacudidas clónicas y cambios de coloración según el tiempo de duración de la hipoxia.
- Autolimitados. No hay somnolencia post-ictal con recuperación completa y presenta una duración de segundos a minutos.
- Tipos:
- Cianótica (80%): Desencadenada por sensación displacentera (frustración, temor o enojo) provocando una apnea espiratoria prolongada.
- Pálida (20%): Desencadenada por estímulo doloroso (traumatismo leve) provocando síncope vasovagal. Puede asociarse a bradicardias. Niños con anemia ferropénica pueden presentar tiempo de asistolia más prolongado durante el espasmo. Ante recurrencia se sugiere valoración cardiológica. Solo en el caso que haya cambios postictales o duración prolongada requiere realización de EEG.

→ Síncope:

- Es el TPNE más frecuentes en la edad escolar - adolescencia y que con mayor facilidad se confunden con crisis epilépticas.
- Pérdida súbita, breve y transitoria de la conciencia y del tono muscular con recuperación completa y espontánea generada por una interrupción temporaria del flujo sanguíneo cerebral. Sin cambios post

ictales.

- Puede presentar síntomas prodrómicos y bradicardia durante el episodio.
- Tipos:

Vasovagal: Desencadenado por estrés emocional (ansiedad miedo) o físico (ayuno, calor, cansancio, defecación, tos, llanto). Suele aparecer en bipedestación y desaparece al acostarse. No aparece durante el ejercicio. El examen físico puede ser normal o presentar pulso débil e hipotensión. A veces puede acompañarse de síntomas vegetativos (mareo, náuseas, palidez, vómitos, acúfenos, visión borrosa, sudoración profusa).

Cardiogénico: Se puede presentar a cualquier edad. Causado por disfunción miocárdica, alteraciones estructurales del corazón y sus vasos o trastornos de la conducción. Suele desencadenarse por ejercicio y presentar antecedentes familiares de síncope o muerte súbita. No presenta síntomas vegetativos, pero sí disnea dolor torácico o palpitaciones. El examen físico puede ser normal o clínico de cardiopatía de base.

- Febril: Más prevalente en lactantes y niños pequeños. Desencadenado por la fiebre.

2. Crisis Psíquicas

→ Crisis psicógena no epilépticas (pseudo-convulsiones):

- Más prevalente en niños a partir de los 5 años y adolescencia.
- Cambios bruscos y autolimitados de las funciones conductuales y/o cognitivas, que no son causadas por descarga neuronal anómala ni causa orgánica conocida.
- Episodios suelen ser muy llamativos, con gritos y llanto, no suelen provocar lesiones. Es característico que se presenten durante el día y en presencia de testigos.
- Se debe tener en cuenta que las pseudocrisis son frecuentes en pacientes con epilepsia, siendo necesario realizar electroencefalograma diferencial. Dicho abordaje terapéutico es complicado y debe ser interdisciplinario.

→ Berrinches o rabietas:

- Prevalente entre los 3 a 6 años de edad.
- Caracterizada por ira provocada y dirigida

a una persona y/o objeto ante una situación de frustración generando crisis bruscas y repetidas de gritos, llanto, revuelco en el piso, agitación motriz, sin respuesta a estímulos. Luego de la crisis puede haber agotamiento o somnolencia e incluso amnesia.

→ Ataques de pánico:

- Más frecuente en la adolescencia.
- Se suele manifestar con sudoración, escalofríos, temblores, opresión precordial, taquicardia, miedo, inestabilidad en la marcha y mareo.
- Fuera del estado de crisis suele existir psicopatología de tipo ansioso o fóbico.

→ Crisis de hiperventilación psicógena:

- Más frecuente en la adolescencia.
- Caracterizan por la sensación de falta de aire y opresión torácica, mareos, palpitaciones, cefalea y hasta parestesias.
- En casos severos puede producir un estado tetaniforme (hiperventilación produce hipocapnia y alcalosis).
- Se debe tener en cuenta que en un buen número de pacientes la hiperventilación se oculta o no se hace de forma consciente pudiendo provocar una crisis epiléptica real.

→ Síndrome de Munchausen por poder:

- ✓ Suele ser más frecuentes en la infancia.
- ✓ Niños son víctimas de crisis inventadas o inducidas por sus padres.

3. Trastornos motores paroxísticos

→ Mioclonías benignas del Recién nacido:

- ✓ Frecuente aparición en los primeros días de vida y ceden antes del 4º mes.
- ✓ Se caracterizan por movimientos bruscos y breves secundarios a contracciones musculares durante el sueño. Pudiendo ser focales o generalizados y afectando cualquier extremidad, predominantemente miembros superiores.
- ✓ Aparecen en el sueño No REM, en clústers pudiendo durar 20-30 minutos y ceden de inmediato al despertar.
- ✓ Se deben a inmadurez de vías serotoninérgicas a nivel del tronco cerebral.

→ **Temblores - tremulaciones**

- ✓ Afectan al 70% de los neonatos en los primeros días de vida.
- ✓ Autolimitados y benignos.
- ✓ Se caracterizan por movimientos rítmicos, y a veces asimétricos, de las extremidades, mentón o paladar.
- ✓ Suelen ser desencadenados por el llanto o al desvestirse. Cediendo al tacto.

→ **Spasmus nutans:**

- ✓ Aparece en lactantes, autolimitado y desaparece entre los 3 y 6 años.
- ✓ Se caracteriza por episodios espontáneos de nistagmo asimétrico asociado a inclinación y movimientos de asentimiento o negación de la cabeza.
- ✓ Dura pocos segundos, pero reiterativo.
- ✓ Hay que descartar la posibilidad de lesiones quiasmáticas o diencefálicas siempre con una neuroimagen. Presenta electroencefalograma normal.

→ **Tics:**

- ✓ Se suelen evidenciar entre los 6-12 años.
- ✓ Se caracteriza por movimiento involuntario agudo, rápido, repetitivo, no rítmico. Pudiendo ser motores o fonatorios, simples o complejos.
- ✓ Tipos:

Tic motor simple: involucra grupo localizado o un músculo en particular (parpadeo, contracción o sacudida cefálica, encoger hombros).

Tic motor complejo: Clúster de acciones simples o secuencia coordinada de movimientos. Pudiendo ser movimiento sin propósito (tocarse el pelo) o aparentemente con propósito, pero inadecuados en contexto (tocar, golpear, sonreírse).

Tic fonatorio simple (carraspeo).

Tic fonatorio complejo (ecolalia, coprolalia).

→ **Coreoatetosis paroxística familiar:**

- ✓ Se suelen evidenciar entre los 6-12 años.
- ✓ Se caracteriza por episodios de movimientos involuntarios uni o bilaterales distónicos o coreoatetósicos que afectan extremidades y cara. De duración variable entre minutos y horas. Periodicidad inconstante.
- ✓ Presenta herencia autosómica dominante con incompleta penetrancia. Hallándose en el cromosoma 14q13: gen TIFT1.

- ✓ Puede desencadenarse por la cafeína, alcohol, ansiedad y fatiga.

→ **Síndrome de Sandifer:**

- ✓ Predominantemente entre los 18-36 meses de vida.
- ✓ Se caracteriza por posturas anómalas del cuello, tronco y extremidades durante o post alimentación. Puede haber cianosis facial, apnea y posición en opistótonos.
- ✓ Secundario a reflujo gastroesofágico, hernia hiatal o disfunción esofágica. El cuadro cede al tratar el reflujo gastroesofágico.

→ **Tortícolis paroxística:**

- ✓ Inicia en el primer año de vida hasta 3-5 años.
- ✓ Se caracteriza por Inclinación lateral del cuello, que provoca dolor al intentar corregirla.
- ✓ Aparición brusca, generalmente por las mañanas, puede durar desde minutos a varios días y cede espontáneamente.
- ✓ Puede acompañarse de palidez, vómitos, irritabilidad, ataxia y nistagmus.
- ✓ Se desconoce etiología, se sospecha relación con migraña, ya que en ocasiones puede evolucionar a vértigo paroxístico y cefalea migrañosa.

4. **Trastornos del sueño**

→ **Terrores nocturnos - Sonambulismo:**

- ✓ Es más frecuente en niños entre los 2-12 años.
- ✓ Aparecen en el sueño no REM. Benignos. Autolimitados.
- ✓ En los terrores nocturnos el despertar es brusco, con un grito de pánico. Pueden asociarse síntomas vegetativos. Tras unos minutos vuelve a dormirse con amnesia de lo ocurrido.
- ✓ En el sonambulismo el niño abre los ojos, se sienta en la cama, camina, realiza actividades inadecuadas. Puede durar varios minutos, es difícil despertarlo y es fácil conducir de nuevo al niño a su cama con amnesia al día siguiente.

→ **Pesadillas:**

- ✓ Son más frecuentes a partir de los 2 años. Disminuyen con la edad y no suelen re-

querir tratamiento.

- ✓ Aparecen en la fase de sueño REM y, por tanto, recordadas al despertar.
- ✓ Son ensoñaciones largas y elaboradas que se relacionan con situaciones angustiosas y amenazantes.

→ **Piernas inquietas**

- ✓ Predomina en la edad escolar.
- ✓ Se caracteriza por la necesidad imperiosa de mover las piernas en situaciones de reposo.
- ✓ El diagnóstico es clínico, por medio de una adecuada anamnesis y un examen físico que excluya otras causas de dolor crónico de las piernas. La confirmación nos la da una polisomnografía.

5. Otros

→ **Migrañas:**

- ✓ Más frecuente en niños mayores de 6 años, luego de la pubertad y adolescencia más prevalente en mujeres. Suele presentar antecedentes familiares de migraña.
- ✓ Se caracteriza por cefalea hemicránea u orbitaria, pulsátil, asociada fotofobia y sonofobia. Náuseas y vómitos. Calma luego de horas de sueño.

- ✓ Tipos:

Clásica o sin aura.

Con aura: el Aura puede preceder 30 min a la cefalea y puede durar varias horas. Son síntomas sensitivos: alteraciones visuales, escotomas, destellos, amaurosis, supliría y alteraciones del campo visual. Parestesias o disestesias. Alteraciones en el lenguaje, disartria, anartria.

→ **Vértigo paroxístico benigno:**

- ✓ Más frecuente en edad escolar.
- ✓ Se caracteriza por episodios breves y bruscos de inestabilidad asociados a facies de angustia, tendencia a quedarse quieto, palidez, sudoración y, a veces, vómitos.
- ✓ Presentan una duración alrededor de un minuto. Sin compromiso de conciencia y recuperación completa.

→ **Vómitos cíclicos:**

- ✓ Se trata de una variante de migraña periódica por lo que responde a los fármacos

antimigrañosos o antiepilépticos.

- ✓ Se ha asociado con mutaciones que también pueden causar una migraña hemipléjica.
- ✓ Deben descartarse causas metabólicas.

EVENTOS PAROXÍSTICOS EPILEPTICOS

Definición

Entidades cerebrales en las cuales las descargas epilépticas contribuyen la disfunción neurológica. Se caracterizan por inicio y fin brusco. Puede haber manifestaciones motoras o cognitivas, focales o generalizadas. Por lo general la duración es breve de escasos minutos. Suelen tener periodo post ictal con somnolencia, confusión y cefalea.

Pueden aparecer a cualquier edad. Para poder realizar la correcta interpretación del síndrome electro clínico requieren estudios de neuroimagen resonancia magnética y EEG. Las causas son variadas: estructurales, genéticas, metabólicas e inmunológicas entre otras.

Síndrome de West

- ✓ Presenta una frecuencia de 1 cada 4000-6000 Nacidos vivos con predominio en varones.
- ✓ Inicia dentro del primer año de vida (más frecuente entre los 4 - 7 meses).

- ✓ Etiología:

Idiopático o criptogénico (20%)

Sintomáticos o secundario (80%):

- ✓ Causas: Encefalopatía hipóxico - isquémica, síndromes neurocutáneos, malformaciones del SNC, alteraciones genéticas (S. de down, S. de X frágil), alteraciones neurometabólicas, infecciosas (TORCH), tóxicas y genéticas.

- ✓ Inicio más precoz con pobre respuesta al tratamiento y peor pronóstico.

- ✓ Presenta una Triada clásica:

Espasmos: contracción muscular breve, repetitiva en salvas, simétricas y bilaterales de músculos del cuello, tronco y extremidades. Pueden ser en flexión, extensión o mixtas. Más frecuentes al despertar.

Hipsarritmia: En el electroencefalograma se observa en los momentos de crisis ondas lentas de gran amplitud asociadas a ondas agudas que siguen a una fase de atenua-

ción del voltaje y desincronización del ritmo de base. En los momentos intercrisis se observa un patrón de base desorganizado que combina ondas agudas y lentas intercaladas hipervoltadas.

Detención del neurodesarrollo: pérdida o retraso en la adquisición de pautas, trastornos del sueño, rechazo al alimento.

✓ Protocolo de estudio:

Examen neurológico completo + Fondo de ojo. Examen dermatológico (lámpara Wood). Tomografía y resonancia magnética de encéfalo.

Ecografía cerebral, abdominal y cardíaca.

Laboratorio: estudio bioquímico general, serología para TORCH y CMV.

Estudios metabólicos:

En plasma: láctico, pirúvico, amonio, aminoácidos, cobre, etc.

En orina: ácidos orgánicos, tiosulfatos, mucopolisacáridos, etc

En LCR: aminoácidos, lactato, piruvato, glucorraquia, etc.

✓ Tratamiento: Se irá escalando en forma secuencial, primero suele utilizarse Pridoxina 300 mg/día por 5 días, ante fracaso se pasa a Vigabatrina 50 - 200 mg/kg/día. Por último, puede indicarse ACTH intramuscular por 2-3 semanas.

✓ Pronóstico: depende de la etiología, del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Más del 50% evoluciona a epilepsia refractaria (Síndrome de Lennox - Gastaut). Presenta una mortalidad del 15 - 20%.

Bibliografía

- Aicardi J. *Diseases of the nervous system in childhood*. 3º ed. Londres. Mac Keith press. 2009
- Campistol Plana J. *Trastornos paroxísticos no epilépticos en la infancia*. Barcelona. Viguera eds. 2014
- García V et al. Actualización del Síndrome de West. *Revista Chilena de Epilepsia*. 2014. 14(3): 34-41.
- Hospital Garrahan. *Series de Pediatría Garrahan. El niño con problemas neurológicos*. 2018
- Muñoz García-Largo L et al. Pseudocrisis en niños y adolescentes: una revisión. *Revista de psiquiatría infanto-juvenil*. España. 2011(1):12-24

ATAXIA

Definición

Es un trastorno del equilibrio y de la coordinación del movimiento voluntario. Provoca un aumento de la base de sustentación y en los casos más graves imposibilidad para mantener la bipedestación. La ataxia aguda puede definirse como una alteración en la marcha y/o en los movimientos motores finos de menos de 72 horas de evolución en un niño previamente sano. Se denomina ataxia cinética si el trastorno aparece en la ejecución del movimiento y ataxia estática si se presenta en la bipedestación o en la deambulación.

Etiología

La ataxia de instauración brusca es una urgencia neurológica. Si bien las principales causas son la ataxia cerebelosa aguda e intoxicación son por lo general benignas y autolimitadas, la ataxia aguda puede ser la manifestación inicial de una enfermedad grave.

De acuerdo con su origen topográfico:

Ataxia cerebelosa aguda

También llamada ataxia cerebelosa postinfecciosa, es de inicio brusco, puede producirse 1-3 semanas después de la varicela (ya no tan frecuente gracias a la inmunización), la mononucleosis infecciosa, alguna enfermedad vírica leve respiratoria o gastrointestinal u otras infecciones. También puede debutar como una respuesta autoinmune dirigida contra la sustancia blanca cerebelosa y precipitada por la infección vírica. Los síntomas comienzan de modo brusco, la marcha es inestable, con los brazos abiertos que tratan de compensarla con aumento de la base de sustentación y oscilaciones del tronco; no empeora con la oclusión palpebral (Romberg negativo). En la exploración puede haber dismetría de los brazos, disartria, nistagmo, vómitos, irritabilidad y letargo. Puede coexistir cefalea y alteración del comportamiento. Los síntomas pueden ser lo bastante intensos como para impedir la bipedestación o la sedestación suele ser máximo a los 2 días para estabilizarse y después resolverse al cabo de 1-2 semanas. Las pruebas de neuroimagen suelen ser normales, aunque se han descrito casos atípicos de hemisferitis

o hidrocefalia obstructiva secundaria a edema cerebeloso. La resonancia magnética encefálica puede mostrar realce del cerebelo. El estudio de líquido cefalorraquídeo puede mostrar pleocitosis linfocitaria y leve elevación de proteínas.

Ataxia Vestibular

El trastorno del equilibrio se caracteriza por la inclinación del cuerpo hacia uno de los lados o hacia atrás. También se descompone en múltiples direcciones en cuyo caso se denomina marcha en estrella. Estas alteraciones aumentan con el cierre palpebral (Romberg positivo), el nistagmo horizontal o rotatorio y el vértigo. Si el síndrome vestibular es periférico se presenta con vértigo paroxístico intenso, náuseas y vómitos. Se asocia a síntomas cocleares (acufenos e hipoacusia).

Ataxia cordonal posterior

Es una ataxia cinética, provocada por la alteración de la sensibilidad profunda de los cordones posteriores de Goll y Burdach. Es brusca, tacañeante, la persona camina mirándose los pies y lanzándolos excesivamente y esto se torna más evidente al caminar hacia atrás. Se acentúa con la oscuridad y al cerrar los ojos.

De acuerdo con su forma de presentación:

Intoxicaciones

Los síntomas se presentan en forma aguda en un niño previamente sano. Suelen estar implicados antitusivos, benzodiazepinas, alcohol y antihistamínicos; puede ser necesario el interrogatorio minucioso para identificar antecedentes de ingestión. Las ingestiones accidentales son más frecuentes antes de la edad escolar, pero alcanzan en máximo en la adolescencia con el abuso de sustancias o problemas psiquiátricos. La ataxia casi siempre se asocia a nistagmo, trastornos de la conciencia, del comportamiento y en casos más graves letargia o el coma. No se acompaña de fiebre. El análisis toxicológico de la orina permite detectar una serie limitada de drogas; hay que realizar las detecciones específicas para los compuestos sospechados.

Infecciones

La ataxia puede ser la primera manifestación de una meningoencefalitis vírica del tronco cerebral. La afección de pares craneales, fiebre y alteración del nivel de conciencia marca la diferencia con los cuadros postinfecciosos. El LCR muestra pleocitosis mononuclear e hiperproteínoorraquia. El absceso cerebeloso es otra causa infecciosa de ataxia, al igual que la laberintitis, neuritis y neuronitis vestibular.

Tumores encefálicos

Alrededor del 50% se origina dentro de la fosa posterior. Los tumores originados en la fosa posterior o en el tronco del encéfalo producen ataxia progresiva con cefalea, que puede ser de comienzo agudo o gradual, pero puede agravarse en forma aguda a consecuencia de una hemorragia o la parición rápida de hidrocefalia. La cefalea, los cambios en la personalidad y los hallazgos anormales en la exploración neurológica congruentes con un aumento de presión intracraneal son frecuentes. Los tumores más frecuentes en esta región son el meduloblastoma, el ependimoma, el astrocitoma cerebeloso y el glioma troncoencefálico.

Traumatismos

En traumas leves se puede presentar el síndrome postraumático en donde aparece la ataxia en forma precoz y se resuelve en días o semanas y las pruebas de neuroimagen son normales. En traumatismos más graves la ataxia es debida a una contusión o hematoma de la fosa posterior y se acompaña de signos de hipertensión arterial. La disección arteria vertebral se produce ante un traumatismo cervical y se presenta en minutos u horas con: Vómitos, vértigo, cefalea occipital, ataxia, disartria, nistagmo, parálisis oculomotoras, hemiplejía, afectación de los pares craneales bajos y alteración de la conciencia.

Migraña y equivalentes migrañosos

La migraña tipo basilar se presenta con ataxia, déficit visual o auditivo, disartria, alteración del nivel de conciencia o parestesias bilaterales. Predomina en chicas adolescentes, aunque se puede producir en cualquier edad. Las características migrañosas orientan al diagnóstico y las pruebas de neuroimagen - punción lumbar son normales.

El vértigo paroxístico benigno los niños pequeños y los preescolares presentan episodios breves de desequilibrio súbito. No ocurre una ataxia verdadera, pero el vértigo es tan intenso que el niño se tira al suelo y a menudo se siente atemorizado y no quiere ponerse de pie o caminar. El nistagmo puede ser evidente, no se altera la consciencia y no ocurre cefalea. El diagnóstico es clínico.

Enfermedades desmielinizantes

La esclerosis múltiple pocas veces se presenta antes de los 6 años de edad. La ataxia aguda, generalmente asociada a fiebre es el cuadro clínico más frecuente. El diagnóstico definitivo no se establece hasta que han ocurrido crisis recidivantes, aunque las pruebas de imagen pueden indicar el diagnóstico después del ataque inicial.

Encefalomielitis aguda diseminada es más común entre los niños de 5 a 8 años y en ella la ataxia se acompaña de encefalopatía y afectación multifocal del SNC. Es habitual encontrar antecedente de infección previa o de vacunación.

En ambas entidades la resonancia magnética craneal es diagnóstica y en la esclerosis múltiple es característico encontrar en la punción lumbar bandas oligoclonales.

Patología cerebrovascular

Los trastornos vasculares como por ejemplo el accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, vasculitis, son infrecuentes como causa de ataxia en los niños; los niños con riesgo de enfermedad tromboembólica (incluida la enfermedad de Kawasaki) tienen más riesgo.

Síndrome de opsoclonus - mioclonus

Se caracteriza por movimientos caóticos, pero conjugados de los ojos (opsoclonus), ataxia y mioclonias. Es frecuente en los 2 primeros años de vida. Puede ocurrir como una entidad postinfecciosa, pero se reconoce claramente como un síndrome cerebeloso paraneoplásico y debe ser motivo para una investigación de neuroblastoma o raras veces otras neoplasias.

Enfermedades hereditarias

La ataxia episódica de herencia dominante se manifiesta por ataques de ataxia y vértigo re-

currentes con una historia familiar de episodios similares.

La ataxia de Friedreich es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por una ataxia lentamente progresiva, lenguaje disartrico, nistagmo y anomalías esqueléticas (pie plano, dedos en martillo y cifoescoliosis progresiva). Suele iniciarse antes de los 10 años de edad y son características la debilidad importante y la pérdida sensorial en la porción distal de las manos y los pies.

Síndrome de Miller Fisher

Se considera una variante del síndrome de Guillain-Barre, aunque también se sospecha que es una variante de encefalitis del tronco del encéfalo. Se manifiesta por ataxia, arreflexia y oftalmoparesia. La mirada vertical está afectada característicamente, pero suele conservarse la mirada horizontal. Se precede de una infección banal en la mitad de los casos y el LCR muestra disociación albumino – citológica. El electromiograma demuestra existencia de polineuropatía.

Reacción Psicógena

Es un trastorno de la marcha que es frecuente en chicas adolescentes y más que una ataxia es una marcha abigarrada y teatral. La inestabilidad mejora con la distracción.

Enfermedades Metabólicas

En general, el primer episodio de estos trastornos se parece a una ataxia aguda; los retrasos o la regresión del desarrollo, el antecedente familiar de trastornos familiares, los síntomas relacionados de alteración del estado mental, los vómitos y la diarrea, los olores corporales inusuales y en última instancia un patrón de recidiva relacionado con la enfermedad, cambios en la alimentación u otros factores estresantes, son congruentes con estos diagnósticos. Son ejemplos: la enfermedad de Hartnup (asociada a aminoaciduria y deficiencia de nicotinamida provocando fotosensibilidad), la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y deficiencia de piruvato deshidrogenasa.

Diagnóstico

Anamnesis y examen físico

- ✓ Es necesario realizar un interrogatorio ex-

haustivo sobre la ingesta accidental o provocada de diferentes sustancias. Se debe efectuar un examen neurológico completo, otorrinolaringológico y oftalmológico con fondo de ojo.

- ✓ Exámenes complementarios
- ✓ Punción Lumbar
- ✓ Catecolaminas en sangre y orina
- ✓ Electroencefalograma
- ✓ Análisis de sangre, orina o contenido gástrico en búsqueda de toxico o sustancias.
- ✓ Neuroimágenes (TAC o resonancia magnética de cerebro o medula)
- ✓ Pruebas vestibulares y laberínticas.

Tratamiento

- ✓ Cerebelitis postinfecciosa: No requiere tratamiento específico
- ✓ Intoxicación: Medidas de soporte y corrección de alteraciones bioquímicas.
- ✓ Infección del SNC: Antivírico o antibióticos en función de la sospecha microbiológica.
- ✓ Tumores de la fosa posterior o traumatismo: Manejo quirúrgico.
- ✓ Enfermedades de base inmunológica: Corticoides, inmunoglobulinas como alternativa a los corticoides. En el síndrome de Miller-Fisher no se ha demostrado que mejore el pronóstico. Extirpación del neuroblastoma en el opsoclonus-mioclonus para neoplásico.
- ✓ Migraña: Analgésicos para la cefalea.
- ✓ Patología cerebrovascular: Valorar antiagregantes plaquetarios/anticoagulantes en caso de isquemia cerebral. Medidas de soporte y manejo neuroquirúrgico en caso de hemorragia cerebral.
- ✓ Enfermedades hereditarias: Acetazolamida en ataxias hereditarias. Medidas dietéticas y suplementos vitamínicos en función de la enfermedad metabólica.
- ✓ Reacción psicógena: En casos graves, valoración psiquiátrica.

PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO

Dependerá de la etiología de la ataxia. Como las causas más frecuentes son tóxicas y posinfecciosas, el pronóstico es bueno, aunque un pequeño porcentaje de estas últimas puede dejar secuelas.

TRASTORNOS DE LOS MOVIMIENTOS

Los trastornos del movimiento o discinesias son un grupo diverso de entidades asociadas a movimientos anómalos excesivos, exagerados, caóticos o explosivos de los músculos voluntarios. En general, se deben a anomalías del sistema extrapiramidal o de los ganglios basales. Los movimientos anómalos se activan por el estrés y el cansancio y a menudo desaparecen durante el sueño. En los casos típicos, son difusos y migratorios, pero se pueden limitar a grupos musculares específicos y quizá no desaparezcan durante el sueño.

Mioclonía

Es una contracción con flexión breve, hipercinética, de un grupo muscular, que origina una sacudida súbita. Puede ser epiléptica y no epiléptica.

Mioclonía no epiléptica se distingue del temblor porque es una contracción simple de un músculo agonista, mientras que el temblor es una contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas.

La mioclonía se observa como una manifestación de varias epilepsias y de encefalopatías infecciosas, tóxicas y metabólicas.

La mioclonía benigna suele observarse durante el sueño y puede ser especialmente marcada en los recién nacidos.

Bibliografía

- Camacho Salas Ana, Rogelio Simon de las Heras, Fernando Mateos Beato. *Ataxia aguda, protocolos actualizados al año 2008*, Asociación Española de Pediatría.
- Gutiérrez Martínez JR, Tomé Nestal C. *Protocolos de Neurología. Ataxia aguda. Bol Pediatr* 2006; 46:56:60
- Ibarra Lilian. *Ataxia. Criterios de diagnóstico y tratamiento en pediatría, segunda edición. Hospital general de niños Pedro de Elizalde.*
- Marcante Karen, Robert M. Kliegman. *Ataxia y trastornos del movimiento. Pediatría esencial, séptima edición.*
- Martínez González MJ, Martínez González S, García Ribes A, et al. *Ataxia de aparición aguda en la infancia: etiología, tratamiento y seguimiento. Rev Neurol* 2006;42:321-4
- Pomeranz Albert J, Swapna Sabnis, Sharon L. Busey, Robert M. Kliegman. *Ataxia. Estrategias diagnósticas en pediatría segunda edición.*

***Dra. Eliana Julián** *Revisora*

Neuróloga Infantil

SÍNDROME DE WEST

Lactante de 5 meses con movimientos de flexión simultánea y rítmica de cabeza y pierna

Hospital Zonal General de Agudos Dr. R. Carrillo de Ciudadela.
Residencia de Clínica pediátrica.



Dra. Carolina Abraldes
Instructora de Residentes

Sumario

El Síndrome de West afecta 1: 6000 niños, entre los 3 y 12 meses, con un pico de incidencia a los 5 meses. Predomina en los varones en un 60%. El pronóstico en general es grave, el retardo mental ocurre en el 90% de los casos, con frecuencia se asocia con déficit motor, trastornos de conducta y rasgos autísticos. La mortalidad es del 5%.

La curación completa con un desarrollo psicomotor normal, solo se observa en algunos casos criptogénicos.

Situación clínica

Leandro es un lactante de 5 meses que es traído por sus papá, al servicio de emergencia, al notar que en los últimos días presenta movimientos de la cabeza y piernas reiteradas veces.

Al interrogar detalladamente se constata que presenta movimientos de flexión simultánea y rítmica de cabeza y piernas, con emisión simultánea de heces y orina. Sus padres lo notan decaído, “desganado” en los últimos días. Curso afebril.

Antecedentes

Recién nacido pre-término, aproximadamente 31 semanas, peso de nacimiento 1800 gr. Apgar

5/7. Padece distress neonatal, que requirió 24hs de ARM (asistencia respiratoria mecánica).

Permaneció 15 días de internado, recibió antibióticos y alimentación endovenosa.

Examen Físico

Buen crecimiento (5.200g). Hipotonía, sin sostén de polo cefálico, succión débil, quejoso, signos de deterioro neurológico.

Fue evaluado por neurólogo infantil y se realizó un electroencefalograma que informa “mezcla caótica de espigas y ondas lentas, voltaje elevado en todo el registro.”

Reflexiones

a - Con los elementos reseñados ¿estaría en condiciones de elaborar un diagnóstico de síndrome?

b - ¿Qué método complementario permitiría realizar un diagnóstico de certeza?

c - ¿Desde la perspectiva de la clínica pediátrica, que consideraciones resultan de utilidad para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad?

El síndrome de West es una de las tres causas más frecuentes de convulsiones en el primer año de vida (luego de las neonatales y febriles).

Se calcula que explica el 50% de los casos de

epilepsias crónicas de ese grupo etario. Predomina en el primer año de vida, con un pico de incidencia entre los 4 y 6 meses; En distintas series predomina en varones (2: 1).

En el E.E.G es característica la hipsarritmia, puntal del diagnóstico.

El conocimiento de las manifestaciones clínicas, los antecedentes asociados, y haciendo una adecuada historia clínica y exploración física, permitirán la derivación oportuna al neurólogo, logrando de forma más temprana el diagnóstico y el tratamiento, mejorando el pronóstico y la calidad de vida del niño.

Durante la lactancia se pueden presentar varios síndromes epilépticos muy heterogéneos.

Las epilepsias graves asociadas con etiologías genéticas, por anomalías cromosómicas o por mutaciones génicas comienzan en los dos primeros años de vida.

El pronóstico de cada uno depende en gran medida del síndrome y de su etiología.

La importancia de la epilepsia en el niño está relacionada con su alta incidencia y con el impacto que produce en el desarrollo del niño y la familia.

Resulta fundamental desde la perspectiva del clínico pediatra, establecer si el fenómeno es de naturaleza epiléptica o si tiene una fisiopatología diferente.

Los trastornos paroxísticos no epilépticos son una causa importante de consulta, siendo trascendental su planteo diagnóstico.

Entre las causas frecuentes de trastornos paroxísticos no epilépticos se encuentran: el espasmo de sollozo, el síncope infantojuvenil, el vértigo paroxístico benigno, las pseudocunvulsiones, las mioclonías neonatales benignas del sueño y las mioclonías benignas de la infancia temprana o Síndrome de Fejerman.

Los trastornos paroxísticos, en la mayoría de los casos, con una correcta interpretación de su forma de presentación clínica, será suficiente para orientar al diagnóstico.

Sin embargo en algunos casos el diagnóstico no es fácil y son necesarios estudios especiales, y siempre es recomendable el seguimiento conjunto con el neurólogo infantil para realizar un

diagnóstico correcto y evitar tratamientos anti-convulsivantes innecesarios.

Comentario

Enfoque clínico de las epilepsias en lactantes

El pediatra frente a un niño que consulta por convulsiones, debe como primera medida descartar que esté desencadenado por alguna patología cerebral, ya sea una agresión actual o asociada a enfermedad cerebral crónica. (ver cuadro 1)

La medida inicial es, por lo tanto, descartar que los episodios convulsivos, sean ocasionados por una patología cerebral aguda, por ejemplo infecciones meníngeas, hipoglucemias, encefalopatías con compromiso vascular, etc.

En estos casos es prioritario, de acuerdo al reconocimiento de su etiología, iniciar el tratamiento de la causa subyacente precozmente,

Convulsiones por agresión exógena o endógena del SNC	Convulsiones epilépticas sintomáticas de encefalopatía aguda o subaguda.	Trastornos metabólicos, traumatismos, enfermedades vasculares, infecciones, tumores, intoxicaciones.
Convulsiones asociadas a enfermedad cerebral crónica o progresiva	Epilepsias sintomáticas: a) secundarias a enfermedad cerebral crónica o progresiva b) Asociadas con lesión cerebral no evolutiva	Tumores cerebrales de crecimiento lento, neuroectodermosis, errores congénitos del metabolismo, encefalopatías progresivas con alteración estructural. Secuelas de daño cerebral
Convulsión sin agresión actual o pasada evidente	Epilepsias idiopáticas Epilepsias cripto genéticas	De etiología probablemente genética Origen oculto.

Tabla 1- Orientación clínica para la investigación etiológica de las epilepsias

Fuente: Adaptado de Serrano-Castro P et al.

independientemente de la administración de drogas anticonvulsivantes.

Existen otras causas, las denominadas patologías cerebrales crónicas o progresivas que provocan convulsiones habitualmente difíciles de controlar, por ejemplo los tumores cerebrales neuroectodermosis, entre otras.

Establecida la presunción diagnóstica, debe identificarse la forma clínica del síndrome epiléptico., para lo cual el médico pediatra debe conocer las asociaciones entre patrones electroencefalográficos y las manifestaciones clínicas, a los fines de poder presumir cuadros evolutivos y eventuales respuestas.

Síndrome de West

- ✓ Es la forma aislada de epilepsia, más frecuente en el lactante
- ✓ Se caracteriza por la tríada clásica de espasmos infantiles
deterioro psicomotor
registro electroencefalográfico de hiparritmias

Etiología

- ✓ Afecta 1: 6000 niños, entre los 3 y 12 meses, con un pico de incidencia a los 5 meses. Predomina en los varones en un 60%.

- ✓ Existen formas criptogénicas (10-15%), idiopáticas (5%) y formas sintomáticas (80%), provocadas por múltiples causas, encontramos factores prenatales congénitos (esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, incontinencia pigmenti, Síndrome de Lowe, fenilcetonuria, lipidosis, etc.); alteraciones cromosómicas (Síndrome de Down), malformaciones del Sistema Nervioso Central (Síndrome de Aicardi); infecciones prenatales (T.O.R.C.H. Lues), infecciones postnatales (meningoencefalitis).

Clínica

Se caracteriza por:

- ✓ Espasmos infantiles: Son contracciones de la musculatura axial en flexión y extensión, simétricos, asimétricos y mixtos; en salvas, veces hasta 100 espasmos. Cada contracción suele durar hasta 2 segundos, seguidos de una fase tónica de hasta 10 segundos de duración.
- ✓ A veces las crisis tienen una expresión mínima., presentando cabeceo o elevación de los ojos.
- ✓ Aparecen tanto en vigilia como en el sueño, pero más frecuentemente durante el despertar o el adormecimiento.
- ✓ Deterioro psicomotor: en las formas criptogénicas, existe previo al inicio de los

Prenatal	Perinatal	Postnatal
Esclerosis tuberosa Neurofibromatosis Sx Sturge-Weber Sx Nevus lineal Hemimegalencefalia Sx Sturge-Weber Sx Nevus lineal Hemimegalencefalia Sx Aicardi Lisencefalia Heterotopias Holoprosencefalia Agenesia del cuerpo calloso Síndrome de Down Microcefalia congénita Infección TORCH	Encefalopatía hipóxico-isquémica Status marmoratum Necrosis isquémica focal y multifocal Encefalomalacia multiquística Hipoglucemia	Meningitis Absceso cerebral Meningoencefalitis Hemorragia subdural Hemorragia subaracnoidea Encefalopatía hipóxico-isquémica Paro cardíaco Tumor cerebral Metabolopatía • Fenilcetonuria • Encefalopatía mitocondrial Fármacos • Teofilina

Gráfico 2 - Etiología Síndrome West sintomático

síntomas un período de normalidad, seguido de una detención de la maduración y luego deterioro.

- ✓ En los casos sintomáticos al existir retraso previo, resulta más difícil evidenciar el deterioro.

Exámenes complementarios:

- ✓ El electroencefalograma de vigilia, permite confirmar el diagnóstico.
- ✓ Presenta un patrón hipsarrítmico definido por una mezcla anárquica de ondas lenta entre 1-7 Hz de gran amplitud (más de 200 mcv), ondas de perfil escarpado y de puntas.
- ✓ Durante el sueño no REM, la hipsarritmia puede fraccionarse. Durante el espasmo se suele observar o bien una atenuación paroxística del voltaje o bien una desincronización.
- ✓ Para el diagnóstico etiológico es necesario realizar otras pruebas, tales como estudios neurometabólicos, neuroimágenes y estudios inmunológicos.

Diagnósticos diferenciales:

- ✓ Mioclonías benignas de la lactancia: Presentan crisis muy parecidas, pero los pacientes no presentan deterioro y el EEG es normal
- ✓ Encefalopatía mioclónica precoz, tiene su inicio antes de los 3 meses con espasmos tónicos y el EEG se caracteriza por un trazado tipo «burst suppression».

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es lograr la suspensión de los espasmos y producir la desaparición de la Hipsarritmia en el menor tiempo posible.

El tratamiento de elección es vigabatrina (VGB) a dosis de 80-200 mg/Kg/día en dos dosis, demostrando mayor eficacia en los casos secundarios a Esclerosis tuberosa y enfermedades metabólicas.

Si ceden los espasmos, el tratamiento se mantiene durante 3 meses.

Si persisten espasmos e hipsarritmia a los 28

días se considera fracaso y se suspende tratamiento en 15 días. Se agrega un fármaco de tercera línea.

Las benzodiazepinas (BDZs) y el topiramato pueden ser útiles.

El ACTH sintético (tetracoxáctido) se utiliza a dosis media de 0.3-0.5 mg/día, por vía intramuscular.

Si no se controlan los espasmos, se puede probar con valproato a altas dosis (50-200 mg/Kg/día).

Evolución

El pronóstico en general es grave, el retardo mental ocurre en el 90% de los casos, con frecuencia se asocia con déficit motor, trastornos de conducta y rasgos autísticos.

La mortalidad es del 5%.

Un factor importante que contribuye a emitir el pronóstico, es si el paciente se clasifica inicialmente como idiopático, criptogenético o sintomático.

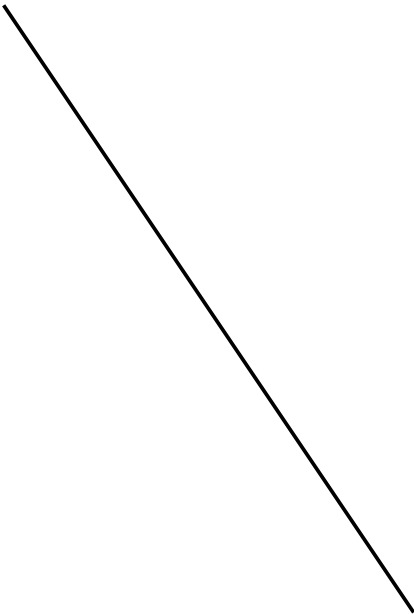
Las formas idiopáticas tienen mejor pronóstico, algunos evolucionan a una epilepsia refractaria de tipo multifocal o a un Síndrome de Lennox-Gastaut.

La curación completa con un desarrollo psicomotor normal, solo se observa en algunos casos criptogénicos.

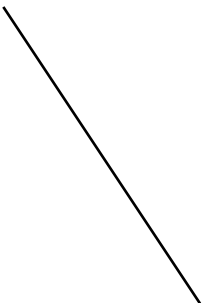
La introducción de la vigabatrina ha mejorado el pronóstico, controlándose las crisis en un 59%-85%.

Bibliografía

- Arce-Portillo E, Rufo-Campo M, et al. Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos. *Rev Neurol* 2011; 52 (2): 81-89
- González JE et al. Guía práctica clínica. Tratamiento farmacológico del Síndrome de West. Unidad de Neurología. Servicio de Pediatría. Hospital Exequiel González Cortés
- Bauzano-Poley E, Rodríguez-Vives M, Rodríguez-Barrionuevo C. Epilepsias y síndromes epilépticos del lactante. Hospital Materno-Infantil, Málaga.
- Morón García GC, Urrutia Torres GJ, Fuentes Cuevas MC. Frecuencia y antecedentes asociados con el síndrome de West. *Archivos de Investigación Materno Infantil*
- Serrano-Castro P et al. Guía de práctica clínica de consenso de la Sociedad Andaluza de Epilepsia.



NÚCLEO SITUACIONES CLÍNICAS



Categoría **K**

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

Residencia de Clínica Pediátrica



Dr. Rodrigo Nicolás Giralda

Residente de 4° año

Dra. María Emilia Acevedo

Jefa de Residentes

Dra. Carina Yafar

Dra. Diana Cabanillas

Instructoras de Residentes

Dra. Verónica Díaz

Revisora

Sala de Oncología

Sumario

En nuestro país el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad entre 5 y 15 años luego de los accidentes, siendo los tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) los segundos en frecuencia, precedido por las Leucemias. El primer lugar en frecuencia lo ocupa el Astrocitoma, del cual presentamos un caso.

Caso clínico

Niña de 6 años que ingresa por vómitos, cefalea y estrabismo de 1 mes de evolución.

Situación clínica

Paciente de 6 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia.

Ingresa por vómitos, cefalea y estrabismo convergente bilateral.

La madre refiere que comenzó un mes atrás con vómitos 2 veces por día, no precedidos por náuseas, ni asociados a alimentación, acompa-

ñados de cefalea hemicraneal derecha que no cedía con ibuprofeno.

En la evolución agrega pérdida de visión de ojo derecho, estrabismo y alteración en la marcha.

Al examen físico se observa niña hemodinámicamente compensada, afebril.

FC 105 lpm FR 20 rpm TA 90/60 mmHg saturación de oxígeno: 98%

P 32Kg (> P97) T118 cm (P75)

Fenotípicamente femenina, estadio de Tanner 1.

Al examen neurológico se constata dismetría a predominio izquierdo, estrabismo convergente bilateral y aumento de base de sustentación.

Reflexión clínica

¿Qué diagnósticos presuntivos sugiere?

¿Qué exámenes complementarios solicitaría inicialmente?

¿Realizaría alguna interconsulta? ¿Con qué servicio?

¿Cómo se confirma el diagnóstico presuntivo?

De acuerdo a los hallazgos de anamnesis y examen físico se asume como un síndrome de hipertensión endocraneana a descartar etiología:

- Pseudotumor cerebri*
- *Masa ocupante de espacio*

Los estudios solicitados inicialmente son el fondo de ojo y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). En el fondo de ojo se observa edema de papila bilateral y en RMN con contraste se informa neoformación a nivel del vermis cerebeloso, sólido-quística con edema perilesional que ocasiona dilatación ventricular supratentorial, con edema transependimario y descenso de amígdalas 13 mm. Realce heterogéneo en porción sólida con área hipointensa (¿necrosis?) sin patología en columna. Los hallazgos descritos

son sugerentes de neoformación de fosa posterior, astrocitoma en primer término. (Figura 1, 2 y 3).

Ante la fuerte sospecha de tumor del SNC y la evidencia de hipertensión endocraneana (edema de papila, descenso de amígdalas) se realiza ateneo en conjunto con Servicio de oncología, neurocirugía, y diagnóstico por imágenes. Se decide ingreso urgente a quirófano para realizar tercera ventriculostomía endoscópica, septostomía y colocación de drenaje al exterior. En segundo tiempo quirúrgico se realiza escisión de 80% del tumor y toma de biopsia.

El diagnóstico se confirma con resultado histopatológico de la lesión que informa astrocitoma pilocítico de fosa posterior. Se solicita estudio molecular en tejido tumoral.

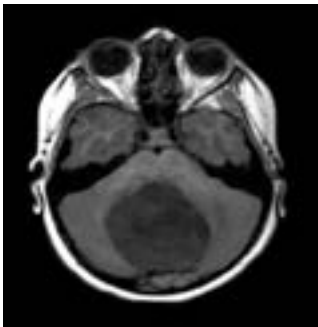


Fig. 1 RMN corte axial T1 sin contraste.

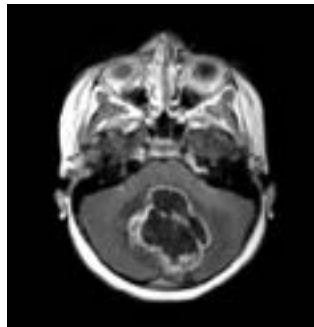


Fig. 2 RMN corte axial T1 con contraste.

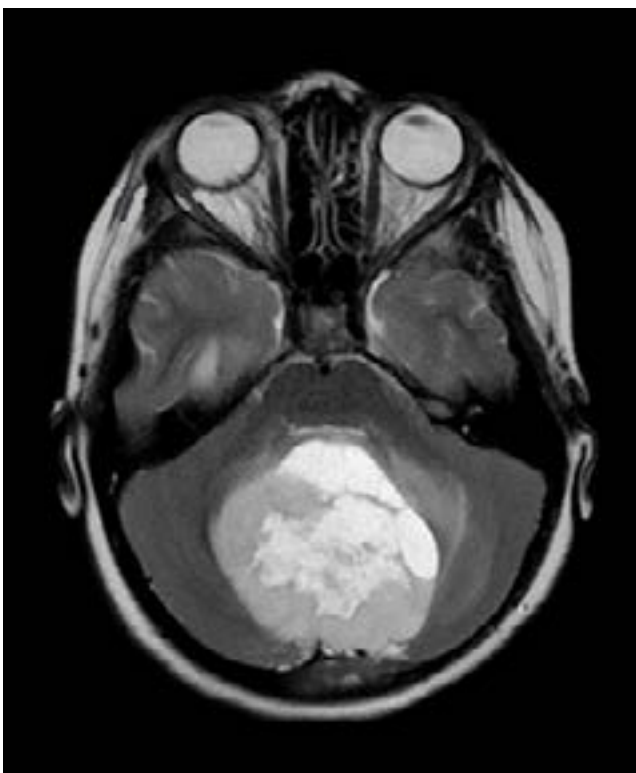


Fig. 3 RMN corte axial T2.

Comentarios

En la República Argentina el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad entre 5 y 15 años luego de los accidentes, siendo los tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) los segundos en frecuencia precedido por las Leucemias. (1)

El primer lugar en frecuencia lo ocupa el Astrocitoma seguido por el Meduloblastoma.

La causa de los tumores de SNC en niños es desconocida pero existen síndromes genéticos predisponentes, entre los más frecuentes Neurofibromatosis 1 y 2, Esclerosis tuberosa, Síndrome de Turcot, Síndrome de Li-Fraumeni. Otro factor de predisposición relacionado es el uso de radioterapia previa en SNC. (2)

Las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales dependen de la edad del niño, la localización, el tipo de tumor y del aumento de la presión endocraneana. (3) (4)

Los síntomas más frecuentemente asociados a tumores cerebrales son: cefalea, vómitos, alteraciones visuales, trastornos motores y convulsiones, manifestaciones endocrinológicas y psiquiátricas.

La cefalea es el motivo de consulta más frecuente durante la infancia. Las cefaleas crónicas, definidas por una duración mayor a 30 días, pueden ser el primer síntoma de un tumor cerebral en niños, principalmente si se trata de una cefalea crónica progresiva (frecuencia diaria, intensidad creciente y síntomas neurológicos

asociados). (5). Se debe prestar particular atención a la cefalea que despierta al niño, aquella acompañada de confusión o desorientación o al cambio de naturaleza de cefalea tensional o migraña ya conocida (6).

Una vez descartadas otras causas más comunes de vómitos, se debe considerar este síntoma como orientador de masa ocupante de espacio a nivel de SNC, principalmente en aquellos pacientes que presenten vómitos matinales y/o con una duración mayor a dos semanas (6).

Como manifestaciones visuales se describen: alteración de la respuesta pupilar, estrabismo repentino, disminución de la agudeza visual y movimientos oculares anormales (6).

La cefalea, los vómitos y las alteraciones visuales son manifestaciones tempranas de hipertensión endocraneana (HTE). En su evolución pueden observarse manifestaciones sistémicas como hipertensión arterial, bradicardia o depresión respiratoria, síntomas que constituyen la denominada tríada de Cushing, signo de gravedad que representa un riesgo elevado de herniación inminente y muerte (7).

El compromiso motor puede variar desde el retraso de pautas madurativas o pérdida de las ya adquiridas hasta alteraciones en el habla, escritura, coordinación, equilibrio o marcha (6).

Los síntomas más comunes por afectación de pares craneales incluyen parálisis facial y trastornos deglutorios.

Las crisis convulsivas pueden ser el síntoma inicial o aparecer en el curso de la enfermedad en niños con tumores supratentoriales. Suelen ser focales y se controlan completamente con el tratamiento de la causa que las origina. (8)

Dentro de las alteraciones endocrinológicas se describen pubertad precoz o retrasada, irregularidades menstruales, obesidad, ginecomastia y diabetes insípida. (6)

En cuanto a las manifestaciones psiquiátricas, los cambios de comportamiento y el letargo son las más frecuentes. (6)

El pediatra cumple un rol fundamental en la etapa diagnóstica, ya que a través de la anamnesis y el examen físico es quien debe sospechar tempranamente la enfermedad y derivar oportunamente. (2)

Las claves para un diagnóstico temprano incluyen un meticuloso interrogatorio, poniendo atención en lo que el niño y padres relatan, incluyendo inicio de síntomas, duración, intensi-

dad y precipitantes de los mismos.

Se debe realizar un examen físico completo procurando tomar la tensión arterial y medir el perímetro cefálico, focalizando en el examen neurológico, aunque la ausencia de alteraciones en el mismo no descarta patología tumoral. (6) (9)

Debe realizarse fondo de ojo para descartar edema de papila y atrofia óptica. (2)

El examen complementario de elección para el diagnóstico de los tumores del SNC es la RMN con contraste (gadolinio). Si este estudio no está disponible, la tomografía axial computada (TAC) con contraste es mandatoria. La TAC simple se utiliza en situaciones en las que se requiere un estudio rápido y sin anestesia con el fin de diagnosticar complicaciones como hidrocefalia descompensada o hemorragia, afecciones que requerirían intervención quirúrgica urgente por el riesgo de vida que condicionan. (8)

Las imágenes deben ser evaluadas por un especialista con experiencia y formación en RMN y TAC de SNC en niños. (6)

Ante la sospecha de cáncer en un niño se sugiere no demorar la referencia a un centro de tercer nivel.

El tratamiento de los tumores del SNC requiere de un abordaje multidisciplinario.

Es primordial el control de la HTE ya que su reconocimiento y tratamiento precoz pueden evitar las secuelas neurológicas e incluso la muerte. Para ello se instauran medidas farmacológicas y/o quirúrgicas. (7)

Una vez alcanzada la estabilidad clínica se planifica el tratamiento específico del tumor.

La cirugía es la base del tratamiento de los tumores del SNC, pudiendo ser curativa como única modalidad terapéutica para los tumores de bajo grado de malignidad.

En tumores no pasibles de control quirúrgico, recidivados o de alto grado de malignidad se indica radioterapia y/o quimioterapia.

Las terapias target moleculares se encuentran en etapa de investigación. (10)

Durante y después del tratamiento pueden presentarse efectos secundarios por lo que deben aplicarse medidas de apoyo. Esto es llevado a cabo por el equipo de cuidados paliativos. Es importante que el paciente y su familia conozcan que los cuidados proporcionados por los profesionales que trabajan en esta área no sólo se aplican en el final de la vida. (11)

El estrés psicológico y los efectos sociales que

la enfermedad genera también requieren de un adecuado asesoramiento y acompañamiento por lo que es importante contar con el apoyo de profesionales que respondan a estas necesidades. (11)

En tumores de SNC la sobrevida se basa en una serie de factores como la edad, la histología, el tamaño, el estadio y la localización por lo que se destaca la importancia de una derivación oportuna para un diagnóstico precoz, factor con marcada influencia en la morbilidad y mortalidad que generan este tipo de patologías.

Según datos del ROHA (Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino) los niños con diagnóstico de tumores del SNC tienen una sobrevida a los 36 meses del 46%, siendo de 38 % en menores de 1 año. (6)

En las últimas décadas se ha logrado mejorar los resultados gracias al uso de terapias combinadas y a la conformación de un equipo de tratamiento multidisciplinario integrado por pediatras, oncólogos, neurocirujanos, patólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes, endocrinología, radioterapia, cuidados paliativos y kinesiólogos.

El retorno a las actividades cotidianas puede ser difícil debido a que los pacientes suelen presentar deterioro neurológico en distintos grados. El pediatra cumple un rol fundamental al acompañar a la familia, ayudándole a focalizarse en los aspectos sanos, y en las fortalezas del núcleo familiar brindando herramientas que promuevan, en el niño, la máxima independencia e integración posible, con la mejor calidad de vida. (12)

Referencias bibliográficas

- 1- Moreno, F; Chaplin, MA. *Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino*. 6ta Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional del Cáncer, 2018.
- 2- Scopinaro, M; Cacciavillano, W. *Detección temprana del cáncer pediátrico*. PRONAP, 2014. Módulo 1. Capítulo 2. Sociedad Argentina de Pediatría.
- 3- Moreno, F; Schwartzman, E. ¿Cuándo sospechar cáncer en el niño?. ROHA y Fundación Hospital Garrahan. *Medicina infantil*. 2007; Vol XIV (2): 191-97.
- 4- Wells, EM; Packer RJ. *Pediatrics Brain Tumors*. Continuum (Minneapolis Minn) 2015;21 (2):373-396.
- 5- Santolin, C; Penido, M; Míguez, R. *Cefaleas en la Infancia*. Reichenbach, JA; Fontana, SM; Gómez, W. *Pediatría en Red*. Primera edición. La Plata: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 2015. Cap.58: 620-25.
- 6- Fischman, M; Ismael, J; Pesce, P; Rufach, D. *Tumores Pediátricos del Sistema Nervioso Central*. Instituto Nacional del Cáncer (INC). Secretaría de Gobierno de Salud-Ministerio de Salud y Desarrollo Social de La Nación. 2005.
- 7- Ballesteros Díez, Y. *Hipertensión endocraneana*. En: Benito, J; Mintegi, S. *Urgencias Pediátricas, guía de actuación*. 2da edición. Madrid: editorial médica panamericana SA; 2019. Sección 2.9: 379-384.
- 8- Martínez González, MJ; García Ribes, A; Garaizar Axpe, C. *Tumores cerebrales infantiles: diagnóstico y semiología neurológica*. *Asoc Esp Pediatr* 2008; 203-8.
- 9- Otero Guerra, R. *Diagnóstico temprano del cáncer en la infancia*. *Rev Soc Bol Ped* 2014;53(3):159-61.
- 10- Díaz Verónica, ¿Cuándo sospechar un tumor de SNC?. *Presentación de un Caso Clínico*. *Ludovica Pediátrica*, Vol 21 (2):10-15.
- 11- Metro, G. *Glioma: guía para los pacientes - Información basada en las Directrices de Práctica Clínica ESMO - v.2016.1*.
- 12- Palladino, M. *El niño curado de cáncer*. PRONAP, 2009. Módulo 2. Capítulo 2. Sociedad Argentina de Pediatría.

DETECCIÓN PRECOZ DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA INFANTIL: “EL QUE BUSCA ENCUENTRA”

Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” de Berazategui.
Servicio de pediatría. Residencia de clínica pediátrica



Dra. Estefanía Barsotti
Dra. Evelina Faraone Berlingeri
Dra. Estefanía Giménez Lanci
Dra. Florencia Belén Miloro
Residentes

Dra. Carolina García
Instructora de Residentes

Dra. Andrea Rodríguez
Jefa de Servicio

Dr. Sebastián Antelo
Revisor
Hemato-oncólogo infantil

Sumario

La detección precoz en patología oncológica pediátrica es la responsable directa de una mayor sobrevida en los pacientes que la padecen.

Si tenemos en cuenta que el 70% tiene una buena y prolongada sobrevida al acceder a un diagnóstico temprano, tratamiento adecuado en tiempo y forma, a un buen estado nutricional y a una red de apoyo socio emocional, esta estadística aparentemente irrelevante, se transforma en la posibilidad de vida para muchos de estos niños.

Caso clínico

Niño de 4 años con cuadro bronco obstructivo, adenomegalías y Rx tórax patológica.

Situación Clínica

Francisco, de 4 años de edad, es traído a guar-

dia hospitalaria por presentar registros febriles y tos productiva asociados a dificultad respiratoria de aproximadamente 48 hs de evolución.

Antecedentes personales: padece desde los 2 años de vida múltiples cuadros de tipo bronquio obstructivos. Cuenta con carnet de vacunas completo para la edad. No se refieren a la anamnesis, antecedentes familiares de relevancia.

Examen físico al ingreso: regular estado general, febril (38,5°C). Palidez generalizada. Auscultación respiratoria con abundantes roncus bilaterales. Tiraje generalizado. Se coloca oxígeno por cánula nasal y se solicita RX de tórax frente y perfil (se observa radio opacidad en hemitórax derecho con índice cardiotorácico >0.33) y hemograma: glóbulos blancos de 10.000/mm³ (formula N:80%/L:12%), Hb:9mg/dl, Hto 31% y plaquetas:140.000.

Presenta concomitantemente múltiples adenopatías de rango adenomegalico en cadena

ganglionar cervical bilateral, axilares, inguinales y en región supraclavicular derecha; por lo que se decide realizar una TAC cervical y torácica en donde se visualiza ensanchamiento mediastinal; y nuevo laboratorio incluyendo LDH (1200 UI/l).

Se realiza interconsulta con hemato-oncología, quien indica biopsia de adenopatía mediastinal.

Diagnostico final: LINFOMA HODGKIN.

Introducción

La oncología infantil engloba un grupo de enfermedades con características, tratamientos y pronósticos específicos, pero de baja frecuencia y con manifestaciones clínicas que simulan patologías benignas o banales; por lo cual el equipo de salud no reacciona con la debida urgencia. Es aquí donde debemos enfatizar, ya que el rol del pediatra como primer contacto con el paciente es de suma importancia para arribar a un diagnóstico precoz y así disminuir el lapso de tiempo entre la aparición de los síntomas y la llegada a un centro de referencia, lo que resultaría en un impacto sanitario trascendental teniendo en cuenta que aproximadamente en un 75-80% de los casos, la curación es posible.

Epidemiología

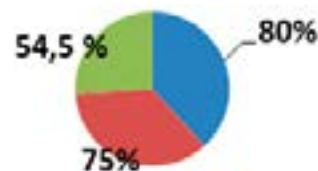
Cada año, en nuestro país se diagnostican 1322 cánceres en la población menor de 15 años. Siete de cada 10 de esos son leucemias, tumores del sistema nervioso central (principalmente, de cerebro) y linfomas.

La sobrevida estimada a los 5 años del diagnóstico para el período 2005-2011 fue aproximadamente del 70%. Respecto a la de los tres tumores más frecuentes fue del 75% para las leucemias, del 54.5% para los Tumores del Sistema Nervioso Central, y del 80% para los Linfomas. El mejor pronóstico lo presentan los Retinoblastomas con una sobrevida a 5 años del 91.4%. El peor pronóstico a 5 años se observa en los Tumores Óseos con el 49.1%, seguido de las Leucemias Mieloblásticas con el 49.2% y los Tumores del Sistema Nervioso Central con el 54.5%.

Los casos registrados anualmente son el 91% de los casos esperados en el país. Aún hay un 10% de pacientes sin incluir dentro del registro. Esto nos dice que quedan fuera del sistema de salud. Por eso, la importancia de la sospecha diagnóstica.

PORCENTAJE DE SOBREVIDA A LOS 5 AÑOS DEL DIAGNÓSTICO...

■ LINFOMAS ■ LEUCEMIAS ■ TUMORES SNC



1

SIGNOS Y SÍNTOMAS

La patología oncológica infantil es de difícil diagnóstico debido a que la sintomatología, al inicio, es similar a cualquiera enfermedad benigna de la infancia. El objetivo es que el pediatra de un centro periférico sepa reconocer cuáles son las características de dichos síntomas que requieran de una atención en particular, para así no desaprovechar este primer contacto con el paciente.

Signos y síntomas inespecíficos más frecuentes

Aumento del tamaño de ganglios

En la población pediátrica, las adenomegalias son parte de las consultas habituales. Por lo general, son parte de procesos benignos y autolimitados, ya sea por infecciones de estirpe viral como bacteriana.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica?

1) Cuando no se trate de masa única sino de conglomerados ganglionares por lo general de distribución unilateral 2) Cuando el tamaño sea mayor a 3 cm. 3) Cuando la localización sea supraclavicular 4) Cuando no exista proceso infeccioso que lo justifique. 5) Cuando no responden al tratamiento antibiótico. 6) Cuando sean indolores o estén adheridas a planos profundos.

Fiebre, púrpura y anemia

1 Fuente: Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino. Tendencia de Incidencia 2000-2016. Supervivencia a 5 años 2005-2011. Tendencia de Supervivencia secular: 2000-04, 2005-09 y 2010-14-6a ed.

Se sabe la fiebre es una respuesta benigna por parte del organismo, ante la presencia de un agente infeccioso. Casi todas las patologías autolimitadas de la infancia cursan con fiebre.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica?

1) Cuando no se encuentra un foco claro de la fiebre 2) Cuando la fiebre persiste más allá de los 14 días 3) Cuando a pesar de haber realizado múltiples esquemas antibióticos (por sobre-diagnóstico médico) el paciente persiste febril. 4) Cuando se asocia a alteraciones del laboratorio como anemia o plaquetopenia.

Dolor de cabeza y vómitos

La cefalea es uno de los síntomas más comunes en pediatría, muy infrecuentemente es causada por un tumor. Lo mismo ocurre con los episodios de vómitos, los cuales son sumamente comunes en la primera y segunda infancia y rara vez se le adjudica el origen a una causa tumoral.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica?

Cuando la cefalea despierta al paciente de noche. 2) Cuando son matinales. 3) Cuando la cefalea es frecuente y severa. 4) Cuando se asocia a manifestaciones neurológicas (afectación de pares craneales, somnolencia, alteraciones visuales, convulsiones, ataxia). 5) Cuando se asocian a vómitos matinales, o “en chorro”, alteraciones del crecimiento, o diabetes insípida. 6) Cuando hay aumento del perímetro cefálico. 7) Cuando hay cambios del comportamiento y/o de la conducta. En lo que respecta a las determinaciones de laboratorio, son de utilidad la ferritina y LDH para el diagnóstico de neuroblastoma.

Masa tumoral mediastinal y masa palpable en abdomen

Gran parte de las masas tumorales mediastinales se identifican de forma accidental ante la realización de una RX de tórax en búsqueda de patologías virales o bacterianas a nivel pulmonar. Lo mismo ocurre con la palpación de masas abdominales ante la realización del examen físico de rutina.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica?

Siempre se debe pensar en patología oncológica ante la presencia de masas mediastinales. No demorarse la derivación, con la realización

de estudios complementarios, si ya se tiene la sospecha clínica. Ante la presencia de masas abdominales, siempre realizar ecografía abdominal, para así descartar patologías de tipo infecciosas como podría ser un absceso hepático, en caso contrario, derivar a centro de oncología pediátrica. En el caso de linfoma de hodking el aumento en la determinación de LDH y ERS nos acercan a su diagnóstico.

Alteraciones en los ojos (Leucocoria, Estrabismo)

Es indispensable examinar los ojos del niño en busca del reflejo rojo de fondo normal. Si en su lugar se observa un reflejo blanquecino, signo que los padres suelen referir como “ojo brillante” “ojo de gato” o “reflejo blanco en la noche”, el niño tiene leucocoria, que es la principal manifestación externa de retinoblastoma. A veces no es fácil detectar este signo en la consulta, incluso moviendo y ladeando la cabeza del niño. En estos casos, si los padres han mencionado este cambio de color en la pupila, la mejor decisión es referir al niño para que le hagan una valoración oftalmológica.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica? Siempre. Se debe derivar al paciente a centro de oncología pediátrica.

Protrusión ocular

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica? Siempre. Los diagnósticos más frecuentes a tener en cuenta son: Rabdomiosarcoma, Histiocitosis, Tumor del Nervio óptico, Leucemia, Neuroblastoma, Retinoblastoma. Ante la consulta descartar causa infecciosa, y luego derivar de forma urgente a centro de oncología pediátrica. Dentro de las determinaciones de laboratorio, son de utilidad la ferritina y LDH para el diagnóstico de neuroblastoma.

Dolor óseo localizado, Dolor óseo generalizado

Los dolores óseos suelen ser atribuidos habitualmente a dolores de crecimiento o a traumatismos. Ambos son muy frecuentes dentro de la edad pediátrica, por lo que la confusión suele ser habitual.

¿Cuándo se debe pensar en etiología oncológica?

Cuando el dolor despierta al paciente de noche

2) cuando a pesar del uso de analgésicos habituales, interfieren en sus actividades 3) Cuando son progresivos 4) Cuando es unilateral, y no presenta antecedente de trauma local. Al sospecharla, la determinación de FAL y ERS aumentadas orientan al diagnóstico.

Diagnóstico

Es fundamental tener en cuenta que sintomatología aparentemente benigna puede llegar a ser el comienzo de una patología grave. Por lo cual se requiere prestar especial atención al relato de los padres, siendo ellos mismos los mejores observadores de los signos y síntomas de sus hijos/as.

La historia clínica es la herramienta más eficaz para recabar datos; incluyendo antecedentes tanto personales como familiares, como lo son la incidencia de cáncer en la familia, la ocurrencia del mismo tipo de cáncer, edad de presentación, bilateralidad en caso de afectación de órganos pares, la multifocalidad, la aparición de varios cánceres primarios en un mismo individuo y si existe defectos del desarrollo (dimorfismo, retraso mental, malformaciones congénitas, entre otras) asociado al cáncer.

En APS como estudios complementarios básicos de acuerdo al cuadro clínico del paciente se solicita hemograma, sedimento urinario y estudios por imágenes, siendo estos la radiografía de tórax y radiografía simple del aparato locomotor.

Dentro de la oncología infantil no se cuenta con pruebas de screening masivas, a no ser de que se tenga la sospecha firme de una patología determinada en donde se puede recurrir a estudios específicos que son gold estándar para su diagnóstico (TC, PET Tc, por ejemplo).

La persistencia de los síntomas y la insistencia de los padres, con consultas repetidas por el mismo motivo no nos debe hacer pensar en enfermedades banales, ya que un retraso en el diagnóstico puede generar aumento de la carga

tumoral, aumento del estadiaje y/o hacer la cirugía más compleja.

La patología oncológica durante la infancia NO ES PREVENIBLE pero se puede DETECTAR PRECOZMENTE, evitando la pérdida de tiempo.

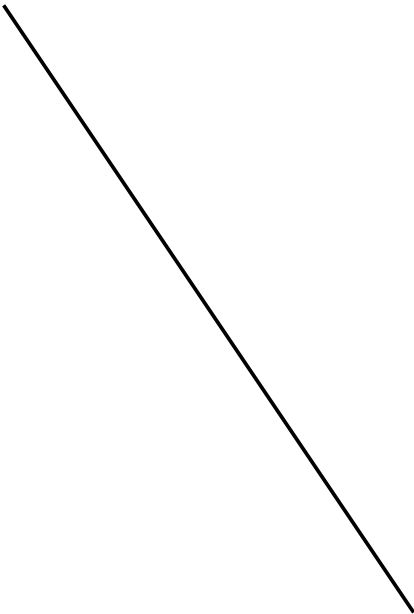
Comentario del Especialista Dr. Sebastián Antelo

“Como pediatra primero y neonatólogo después, formado en un sistema de salud pública en un hospital general de la provincia de Buenos Aires, aprendí que realizar un exhaustivo examen físico puede llevar a muchos posibles diagnósticos, de ahí la importancia de la semiología.

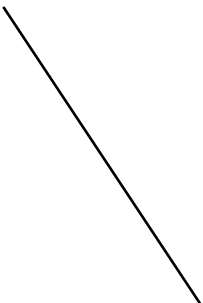
Uno como profesional puede orientar el diagnóstico y facilitar el paso al siguiente nivel de salud. Es muy importante que, desde donde nos toque, siempre estemos atentos, busquemos y pensemos en la patología específica. Las enfermedades hemato-oncológicas en la infancia representan la segunda causa de muerte en niños menores de 15 años”.

Bibliografía

- Acha García T. Diagnóstico precoz y signos de alarma en oncohematología pediátrica. En AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 2015. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2015: 177-86.
- García Hernández B. Sospecha de cáncer en pediatría. *Pediatr Integral* 2008; XII (6):537-544.
- Losa Frías V, M. Herrera López, I. Cabello García, P.I. Navas Alonso. Diagnóstico precoz de cáncer infantil en atención primaria” *Pediatr Integral* 2016; XX (6): 367-379.
- Moreno Florencia, Ana Rizzi, Guillermo Chantada, Lidia Fraquelli, Enrique Schwartzman. Cuando sospechar cáncer en el niño. Ministerio de Salud de la Nación. Instituto Nacional de Cáncer. Septiembre 2016.
- Moreno Florencia; Chaplin María Agustina. Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino Tendencia de Incidencia 2000-2016. Supervivencia a 5 años 2005-2011.Tendencia de Supervivencia secular: 2000-04, 2005-09 y 2010-14- 6a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional del Cáncer; 2018
- Organización Panamericana de la Salud. Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Washington, DC: OPS; 2014.
- Scopinaro M, Cacciavillano W. Detección temprana del cáncer pediátrico. PRONAP 2014. Modulo: 1, Capítulo 2.



NÚCLEO **SITUACIONES CLÍNICAS**



Categoría **L**

DESARROLLO PUBERAL

Hospital General de Agudos Magdalena V. de Martínez de Pacheco.
Servicio de Pediatría.



Dra. Elizabeth Rizzo

Instructora de Residentes

Dr. Jonatan Ezequiel Rojas

Jefe de Residentes

Dra. María Emilia Breppe*

Revisora

Sumario

El desarrollo puberal es un proceso biológico en el que intervienen factores neuroendocrinos, sociales, culturales, ambientales y genéticos.

La pubertad es una etapa de transición entre la niñez y la adultez y, comienza con la adquisición paulatina de los caracteres sexuales secundarios, finalizando con la adquisición de la capacidad reproductiva.

Dentro de la cronología de los eventos puberales hay una amplia variación entre personas sanas que responde a diferentes patrones étnicos, familiares, genéticos y que también se ven influenciados por factores y disruptores endocrinos. Por lo tanto, el comienzo de la pubertad sigue lineamientos estadísticos para una población determinada que se encuentran dentro del intervalo de $\pm 2,5$ DE (desviación estándar).

Caso clínico

Concurre al consultorio una familia Manuel y Camila junto con su mamá, cuya preocupación es que Manuel dejó de crecer, comparado con su hermana que ya lo alcanzó.

Como antecedentes, son niños RNT/PAEG, se

encuentran sanos sin internaciones previas y sin enfermedades crónicas.

En el examen físico, Manuel 12 años y 2 meses con peso 40 kg (pc 50), talla 1.45 cm (pc 50), eutiroideo, Tanner 2, testes 4 cc ambos. Tiene una velocidad de crecimiento 6 cm/año. Edad ósea acorde para edad.

Camila 10 años y 10 meses con peso 50 kg (pc 97), talla 1.46 cm (pc 50-75), eutiroidea Tanner 3. Tiene una velocidad de crecimiento 10 cm/año. Edad ósea acorde para edad.

Ambos crecen por su talla objetivo genético.

Se explica a la madre que son eventos normales, dado que el mayor crecimiento (pico puberal) son en diferentes etapas en el desarrollo de cada niño según su sexo y edad.

Camila presenta velocidad de crecimiento puberal mientras que su hermano lo tendrá dentro de unos años.

Introducción

La cascada de eventos que va a dar comienzo al desarrollo puberal comienza con un aumento en la secreción pulsátil de GNRH (que comenzó aproximadamente 3 años previos) lo

que provoca secreción de LH y FSH, que van a ser las responsables del aumento de tamaño y maduración de las gónadas y de la secreción de hormonas sexuales (en el ovario estradiol y en las células de Leydig del testículo testosterona). Estos esteroides sexuales van a ser los encargados del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la adquisición del pico de masa ósea, grasa, muscular y de la talla adulta.

En las niñas la aparición del botón mamario (telarca) es el primer signo del desarrollo aproximadamente entre los 8-13 años. Este botón mamario puede comenzar de forma unilateral, generando alguna asimetría, la mayoría de las veces normal.

También el botón mamario conlleva a un aumento de la zona areolar con aumento de la sensibilidad de la zona que puede generar algo de dolor y molestia al contacto con la ropa interior.

La *Telarca* antecede a la menarca en 2 años aproximadamente, seguido de la aparición de vello púbico a los 6-12 meses. Con respecto al pico de velocidad de crecimiento se produce en forma temprana (estadio mamario II-III) y es previo a la menarca.

La *menarca* se produce a los 12.5 años aproximadamente.

En los niños el crecimiento de los testículos (+ de 4 mm de volumen o más de 2.5 cm de diámetro mayor) es el primer signo de desarrollo puberal. Luego se van a observar cambios en la pigmentación del escroto y del aumento del pene para luego aparecer el vello púbico.

A diferencia de las niñas la aceleración del crecimiento comienza después del comienzo de la pubertad. Su máxima expresión se da en el estado genital IV-V (estirón puberal).

Estadios de Tanner

El conocimiento acerca del estadio puberal en el adolescente es un requerimiento importante para los estudios o encuestas sobre salud en la adolescencia; muchas variables biológicas, psicológicas y sociales están relacionadas con este indicador de maduración física.

Debido a la variación individual de la edad en que ocurre la pubertad en niños, la edad cronológica es un indicador poco seguro para la estimación de los estadios puberales, por tal motivo se debe evaluar el desarrollo sexual específicamente.

El método usado en forma generalizada hasta la actualidad es el descrito por Tanner en 1962, quien diseñó un método basado en estadios para poder valorar los distintos grados de madurez sexual.

Para la evaluación en ambos sexos, se observan por separado mamas (M) y vello púbico (VP) en las mujeres, y genitales (G) y vello púbico (VP) en los varones.

Examen físico Generalidades

El examen genital es importante para poder valorar el desarrollo, aunque a veces es difícil lograrlo en la primera consulta, es meritorio que se respete la decisión del paciente, preguntar si desea entrar solo o acompañado, y ofrecerle la opción de ser revisado por un médico del mismo sexo.

Los niños deben ser informados sobre el examen y las razones del por qué es necesario y debe pedirse el consentimiento antes del examen. Deben respetarse la privacidad y confidencialidad.

Siempre se le debe avisar lo que se le va a examinar. Si el niño no está a gusto con un examen genital, no debe forzársele.

Para los lactantes y niños preescolares, los padres del niño o el cuidador deben permanecer cerca del niño a lo largo del examen. El examen debe hacerse despacio y cuidadosamente para minimizar incomodidad y dolor.

Si no desea ser evaluado en esta consulta se debe dejar en claro la importancia de hacerlo en la próxima. Mientras tanto se puede mostrar fotografías con los estadios de Tanner para que ellos mismos identifiquen en que estadio se encuentran y aprovechar este recurso visual para explicar los cambios que vendrán.

Examen físico de los genitales femeninos

El examen físico en las mujeres debe evaluar mamas y vello pubiano para realizar la estadificación de Tanner, observar y palpar:

- ✓ Botón se realiza por palpación
- ✓ Areola coloración y forma
- ✓ Contorno mamario
- ✓ Explicar la autoexaminación y hueco mamario
- ✓ Vello pubiano la extensión del mismo
- ✓ Es importante poder evaluar las caracte-

rísticas de los genitales externos (malformaciones, permeabilidad del himen, presencia de infecciones, y/o flujo).

- ✓ Conviene además tomar nota sobre vello axilar y olor apócrino el comienzo del mismo y las medidas de higiene.

Examen físico de los genitales masculinos

El examen se efectúa mediante la inspección y la palpación. Las partes que se deben identificar son:

- ✓ el vello pubiano
- ✓ el pene
- ✓ el glande

Estadios de Tanner en mujeres

Estadio	Vello Pubiano (VP)	Mamas (M)
I	Preadolescente o prepuberal. No se observa vello púbico.	Prepuberal
II	Pubarca: comienza a aparecer vello escaso, con leve pigmentación, suave y lacio, en margen medio de los labios mayores.	Telarca: aparece el botón mamario (al inicio solo por palpación); areola y pezón se elevan ligeramente. Inicio de pubertad en mujeres.
III	El vello es más oscuro, comienza a rizarse, aumenta en número y volumen.	La mama y la areola crecen, no hay separación de contornos.
IV	Irregular, rizado, muy pigmentado y abundante, no alcanza la cara interna de los muslos.	Areola y pezón forman una elevación secundaria respecto del resto de la mama.
V	Distribución de tipo adulto, con límite superior horizontal, y llega lateralmente hasta la raíz de miembros inferiores.	Mamas adultas. Solo se proyecta el pezón sobre la mama y la areola integra su contorno.

Estadios de Tanner en varones

Estadio	Vello Pubiano (VP)	Genitales (G)
I	Preadolescente. No se observa vello púbico.	Preadolescente
II	Pubarca: Crecimiento de escasos vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados lacios o levemente rizados, principalmente en la base del pene.	Gonarca: los testículos aumentan de tamaño a la palpación (vol. > 4 ml), el escroto se ve rosado (por aumento de la vascularización), al inicio de aspecto rugoso. Inicio de pubertad en varones. Pene: similar al estadio prepuberal.
III	Vello más oscuro y áspero, comienza a rizarse, aumenta en cantidad y grosor. Se extiende en forma irregular sobre el pubis.	El escroto se vuelve más rugoso, y la piel escrotal se oscurece. Aumento testicular. Pene: aumenta de tamaño a predominio longitudinal.
IV	Burdo, rizado, pigmentado, abundante, no hay extensión hasta cara media de muslos.	Aumenta aún más la rugosidad y pigmentación del escroto. Continúa el crecimiento testicular. Pene: el tamaño aumenta en diámetro, se desarrolla el glande.
V	Vello de tipo adulto en calidad y cantidad, lateralmente llega hasta raíz de miembros inferiores y puede extenderse hasta línea alba.	Desarrollo completo de genitales, con apariencia adulta.

NIÑAS

GRADOS DE DESARROLLO DEL VELLO PUBIANO



Grado 1 Prepuberal:
El vello sobre el pubis es igual al de la pared abdominal, es decir, no hay vello pubiano.



Grado 2:
Crecimiento de vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente a lo largo de los labios mayores. Este estadio es muy difícil de reconocer en las fotografías.



Grado 3:
El vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado. Se extiende en forma de rala sobre el pubis.



Grado 4:
Las características del vello son de tipo adulto pero la superficie cubierta es todavía menor que en el adulto.



Grado 5:
Vello adulto en calidad y cantidad, con límite superior horizontal.



Grado 6:
Extensión hasta la línea alba.

DESARROLLO DE MAMAS



Grado 1 Prepuberal:
Solamente elevación del pezón.



Grado 2:
Mamas en etapa de botón; elevación de la mama y pezón en forma de un pequeño montículo.



Grado 3:
Mayor agrandamiento y elevación de la mama y la areola, sin separación de sus contornos.



Grado 4:
Proyección de la areola y pezón para formar un montículo secundario por encima del nivel de la piel de la mama.



Grado 5:
Etapa de madurez: proyección del pezón solamente, debido a la recesión de la areola al nivel de la piel de la mama.



NIÑOS

GRADOS DE DESARROLLO DEL VELLO PUBIANO



Grado 1 Prepuberal:

El vello sobre el pubis es igual al de la pared abdominal, es decir, no hay vello pubiano.



Grado 2:

Crecimiento de vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados lacios o levemente rizados, principalmente en la base del pene. Este estado es muy difícil de reconocer en las fotografías.



Grado 3:

El vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado. Se extiende de forma rala sobre el pubis.



Grado 4:

Las características del vello son del tipo adulto pero la superficie cubierta es todavía menor que en el adulto. No hay extensión a la superficie medial de los muslos.



Grado 5:

Vello adulto en calidad y cantidad. Extensión hasta la superficie medial de los muslos.



Grado 6:

Extensión hasta la línea alba.

DESARROLLO DE GENITALES



Grado 1 Prepuberal:

Los testículos, escroto y pene son del mismo tamaño y proporciones que en la primera infancia. Estadío Prepuberal.



Grado 2:

Agrandamiento del escroto y testículos. La piel del escroto se congestiona y cambia de textura. En esta etapa hay poco o ningún agrandamiento del pene.



Grado 3:

Agrandamiento del pene que tiene lugar al principio sobre todo en longitud. Los testículos y el escroto siguen desarrollándose.



Grado 4:

Aumento de tamaño del pene que crece en diámetro, y desarrollo del glande. Los testículos y escroto se hacen grandes, la piel del escroto se oscurece.



Grado 5:

Los genitales son adultos en tamaño y forma.

- ✓ el meato uretral
- ✓ el escroto
- ✓ los testículos
- ✓ los epidídimos
- ✓ los cordones espermáticos

El vello genital o pubiano puede ser abundante en el adolescente y continuarse hacia el ombligo. En los pacientes no circuncidados es necesario retraer el prepucio para examinar el glande y el meato uretral.

El escroto y su contenido.

En la superficie del escroto se pueden encontrar lesiones de aspecto amarillento que corresponden a quistes sebáceos.

En el examen de los testículos es frecuente encontrar el izquierdo más abajo que el derecho. Para palparlos se trata de presentarlos de modo de facilitar el examen. Para esto se toma un testículo entre los dedos medio y anular de cada mano, dejando los dedos índice y pulgar libres para que puedan palpar la superficie de la glándula. También se podrían palpar usando los dedos pulgar, índice y medio. Cuando el músculo cremasteriano retrae los testículos el examen se dificulta y es necesario traccionar un poco el testículo para asirlo en forma adecuada.

En los adolescentes se recomienda el examen testicular en la ducha, puede ser un buen momento para efectuarlo.

También se debe examinar los epidídimos, los conductos deferentes y el cordón espermático. Los epidídimos se palpan como un cordón que sigue el borde posterolateral de los testículos y que es más grueso en el polo superior. Los conductos deferentes, cuando son normales, se palpan como cordones lisos, indoloros y forman parte de los cordones espermáticos. Si existe una hernia inguinoescrotal, el volumen de ese lado del escroto se aprecia abultado.

Volumen testicular

Se utilizará el orquidómetro de Prader que permite comparar el volumen en centímetros cúbicos, con un modelo de madera u otro material. El volumen testicular se utiliza para evaluar ma-



Orquidómetro de Prader

duración sexual (es complementario al EMS de Tanner) y para diagnóstico o control en pacientes con patología testicular, por ejemplo: varicocele, tumor testicular, orquidopexia. Se deben medir ambos testículos. Cuando no se dispone de orquidómetro se puede realizar medición con regla del eje mayor del testículo.

Bibliografía

- Diana P, Alfredo L. "Manual de adolescencia y salud. Un abordaje integral". 1st ed. Journal; 2016.
- Kliegman, Stanton, St. Geme & Schor. "Nelson, Tratado de Pediatría". 20th ed. Elsevier; 2016.
- Ministerio de Salud de la Nación, Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef Argentina. Guía de recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad". 2010.
- OPS. Normas de Atención de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes. Integración del Manejo de Adolescentes y sus Necesidades". Pág. 194-209. OPS; 2005.
- Reichenbach J, Fontana S, Gómez W. "Pediatría en Red" Cap. 31 SAGIJ Ginecología infanto-juvenil. Un abordaje interdisciplinario". Ediciones Journal; 2015
- Sociedad Argentina de Pediatría. Guía para la evaluación del crecimiento Físico. Pág. 115-120. 3rd ed.
- Soriano Guillén L, Argente J. Desarrollo y pubertad en el ser humano. 2nd ed. Rev. Esp. Endocrinol. Pediatr. [Internet]. 2017.

*Dra. María Emilia Breppe Revisora

Médica Endocrinóloga Infantil. Hospital Militar Central, Hospital Materno Infantil de Tigre

PUBERTAD PRECOZ Y TARDÍA

Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.
Servicio de Pediatría.



Dra. Verónica Pisauri

Pediatra, Endocrinóloga infantil

Dra. Georgina Rossi

Pediatra, Especialista en Adolescencia

Dra. Alejandra Coca Salazar

Dr. Álvaro Zamo

Residentes

Dr. Jorge Larcamón

Jefe de Servicio de Pediatría

Dra. Verónica Figueroa Gacitúa*

Revisora

Dra. Laura Diana Milgram**

Revisora

Sumario

La pubertad es el proceso biológico en el que ocurre la maduración física y por el cual un individuo alcanza la madurez fisiológica necesaria para lograr la capacidad de reproducirse.

Por otra parte, la adolescencia es un período de la vida que incluye la pubertad pero abarca también el conjunto de cambios psicosociales que permiten al niño alcanzar la adultez, es decir la capacidad de independencia y autonomía.

Caso clínico 1

Niña de 7 años con sangrado vaginal, desde hace 2 semanas, con presencia de tumoración mamaria.

Situación clínica

Niña de 7 años y 3 meses de edad que, presenta episodio de sangrado vaginal que remite espontáneamente, refiere que desde hace dos meses previos presenta tumoración mamaria y crecimiento de vello pubiano y axilar. No pre-

senta dolor abdominal ni otros síntomas. Antecedente personales: Intervención quirúrgica por canal atrio ventricular; no presenta antecedente familiar de precocidad sexual. La edad de menarca de la madre era de 15 años y un hermano con comienzo de caracteres sexuales a los 12 años. Al examen físico, Edad 7.3 Peso: 31 Kg (+1.7 SDS) Talla: 121 cm (0.15 SDS) IMC 21.1 (+2 - +3 SDS); presenta telarca 2/3, pubarca y axilarca 2, cicatriz de intervención quirúrgica en tórax, abdomen no doloroso, sin masas ni adenomegalias palpables.

Reflexiones

¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? ¿Qué conducta tomaría? ¿Cuál sería su plan de estudio?

La sospecha diagnóstica es Pubertad precoz. Se realiza Rx de mano y frente (que muestra una EO de 9 años), se solicitaron estudios hormonales (TSH, T4L, LH, FSH, estradiol), se solicita ecografía ginecológica con medición de útero y ovarios, se realiza TAC abdominal, interconsulta

con Endocrinología pediátrica.

Se recomienda la necesidad por parte del pediatra de realizar controles semestrales, en las pacientes entre los 6 y 8 años de edad para detectar tempranamente la aparición de signos de desarrollo sexual precoz y realizar la oportuna derivación para seguimiento y tratamiento por especialista.

Comentarios

La pubertad, período de transición entre la niñez y la adultez, se manifiesta inicialmente por la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como consecuencia de cambios hormonales que progresivamente conducen a la madurez sexual completa. Este proceso ocurre por la adecuada maduración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (H-H-G) que consta de tres componentes principales: 1) el GnRH (péptido liberador de gonadotrofinas), secretadas en forma pulsátil por neuronas especializadas del hipotálamo, 2) los gonadotropos hipofisarios, que como respuesta al GnRH sintetizan y liberan las gonadotropinas LH y FSH, 3) las gónadas, que en respuesta a las gonadotrofinas y a un sistema de regulación autocrina y paracrina producen esteroides sexuales y péptidos gonadales que regulan el eje mediante mecanismos de retroalimentación.

La edad de la pubertad en el ser humano está fuertemente influenciada por factores genéticos, étnicos, nutricionales y del medio ambiente. En la niña, la edad de 8 años es aceptada ampliamente como límite para el inicio del desarrollo puberal, que se evidencia habitualmente por el comienzo de desarrollo mamario o telarca. En EEUU y Europa, desde el siglo XIX, se había registrado un adelanto en la edad de la menarca (tendencia secular), como consecuencia de las mejores condiciones de vida pero en las últimas tres décadas esta tendencia parece haber cesado, ya que se ha observado sólo un leve adelanto de la edad de menarca. (1)

A diferencia de la menarca, la edad de inicio de la telarca se ha adelantado debido al incremento de obesidad infantil (1,2) y a otros factores como los disruptores endocrinos (DE) que son sustancias exógenas, que se encuentran en el medio ambiente o alimentos y que interfieren con la producción, liberación, transporte, metabolismo o acción biológica de las hormonas del sistema reproductivo. Las sustancias estrógeno-símiles

pueden producir adelanto del desarrollo mamario dependiendo del tiempo y del momento de la exposición. En Argentina el último estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en mujeres adolescentes sanas de todo el país muestra un promedio de edad de menarca de 12,45 años (3) mostrando poca diferencia con los datos anteriores de 1980, en el cual el promedio fue de 12,53 años.(4) Hasta que se disponga de nuevos estudios poblacionales se recomienda mantener el límite de 8 años como comienzo normal de la pubertad. Se presenta una revisión del tema con el fin de alertar al pediatra sobre distintos tipos de desarrollo sexual precoz para una adecuada derivación al especialista en endocrinología infantil.

Desarrollo sexual precoz (DSP)

En la niña, se define como la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad.

Pubarca Precoz

La pubarca precoz es la aparición aislada de vello pubiano antes de los 8 años de edad. En la mayoría de los casos se debe a la maduración prematura de la zona reticular de la corteza suprarrenal con incremento de los andrógenos suprarrenales, siendo el predominante el sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) (5) que se considera marcador bioquímico de adrenarca. En algunos casos, la pubarca precoz puede ser la primera manifestación de una forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita (HSCNC) por deficiencia de 21-hidroxilasa. En una población Argentina de 100 niñas con pubarca precoz estudiadas en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (HNRG) se observó una prevalencia de 5% de HSCNC por deficiencia de 21 hidroxilasa.(6) Se ha descrito en niñas con pubarca precoz un leve aumento de la velocidad de crecimiento (VC) y de la edad ósea, sin repercusión sobre la talla final.(7)

La pubarca precoz fue considerada un proceso benigno sin repercusión en la vida adulta, aunque ha sido descrita en asociación con alteraciones hormonales y metabólicas desde la prepubertad y señalado su relación con el antecedente de retardo de crecimiento intrauterino, especialmente cuando existe ganancia ponderal excesiva durante la niñez.(8) En la evolución a

largo plazo de niñas con pubarca precoz se ha descrito leve adelanto de la menarca (9) y en la adolescencia anovulación, hiperandrogenismo, dislipidemia e insulinoresistencia. En la experiencia de los autores del presente artículo, las pacientes con historia de pubarca precoz presentaron hiperandrogenismo bioquímico y anovulación en 54% de los casos. (11,12)

Telarca Precoz

Se denomina al desarrollo mamario aislado antes de los 8 años. Es frecuente su aparición antes de los dos años de edad, lo que puede explicarse por la actividad del eje HHG en esta etapa, que se manifiesta por niveles circulantes elevados de FSH y estradiol.(13) Fuera de este período la telarca precoz puede deberse al contacto con DE(disruptores endocrinos) por vía transdérmica (cremas de belleza o productos capilares), oral (por ingestión accidental de medicamentos hormonales, alimentos provenientes de animales tratados con hormonas o alimentación rica en fitoestrógenos) o a través de la lactancia materna (anticonceptivos).(14,15) Los DE pueden actuar en forma similar al estrógeno, como ciertos detergentes, bifenilos policlorinados, herbicidas y pesticidas; estas sustancias se encuentran contaminando el agua, y podrían estar involucrados en la génesis de la TP.

El diagnóstico se confirma por la desaparición de la telarca al eliminarse la fuente de contacto. En los casos en que no se encuentra la causa se define como telarca precoz idiopática (TPI). (16) La TPI es la forma más común de telarca precoz. Los estudios de evolución de niñas con TPI muestran que en el 50% el desarrollo mamario se mantiene estacionario (pero con menos trofismo) y en un tercio desaparece espontáneamente. En la División de Endocrinología del HNRG se analizaron las causas de telarca precoz y su evolución en 96 niñas, de las cuales, el 72% se diagnosticaron como TPI y de ellas el 7,3% evolucionó a PPC, sin que hubiera elementos clínicos o de laboratorio que predijeran esta evolución. Por otro lado, 72% de las niñas con TPI iniciaron pubertad entre los 8 y 9 años, edad más temprana que la normal en la población argentina. (17) Mientras la TPI no necesita tratamiento, la PPC sí lo requiere porque su evolución espontánea tiene consecuencias desfavorables. Es por ello fundamental diferenciar

ambos cuadros y reforzar el control evolutivo de estos casos.

Pubertad Precoz Central

El criterio clásico para definir Pubertad Precoz (PP) en la niña es el comienzo de desarrollo mamario a una edad menor a 2.5 DS de la media de la edad normal para una determinada población. En base a esta definición, en la población estudiada, se considera como límite la edad de 8 años. A pesar del adelanto antes mencionado respecto a la telarca, se recomienda no variar la edad de evaluación diagnóstica para evitar el riesgo de no identificar niñas entre 7 y 8 años de edad con PP rápidamente progresiva o con patología del SNC subyacente. (1) La PPC es prevalente respecto a la pubertad precoz periférica, por lo que se hace referencia exclusivamente a la primera. La PPC muestra dimorfismo sexual siendo más frecuente en niñas que en varones con una relación entre 10:1 hasta 20:1. La edad de presentación prevalece entre los 6 y 8 años de edad.

Diagnóstico de pubertad precoz

El diagnóstico se basa en el interrogatorio, el examen físico, estudios por imágenes y se confirma con estudios de laboratorio que evidencian el estado de activación puberal de eje HHG.

CUADRO CLÍNICO

El primer signo de pubertad precoz en la niña es habitualmente la telarca. Posteriormente o en algunos casos simultáneamente aparece el vello pubiano, y por último el primer sangrado menstrual o menarca. La secuencia de los cambios puberales es similar a la pubertad normal en la mayoría de los casos de PPCI.

La anamnesis debe incluir la historia familiar (edad puberal de familiares en la rama materna y paterna) y posibilidad de contacto con DE. La evaluación antropométrica completa es fundamental, es de gran utilidad contar con medidas de talla previas a la consulta que permitan calcular la velocidad de crecimiento (VC). En la pubertad precoz central es característica la aceleración de la VC (mayor al percentilo 75).

En el examen físico se suele constatar desarrollo mamario grado II-III de Tanner progresivo, con mamas tróficas y mucosa vulvar estimula-

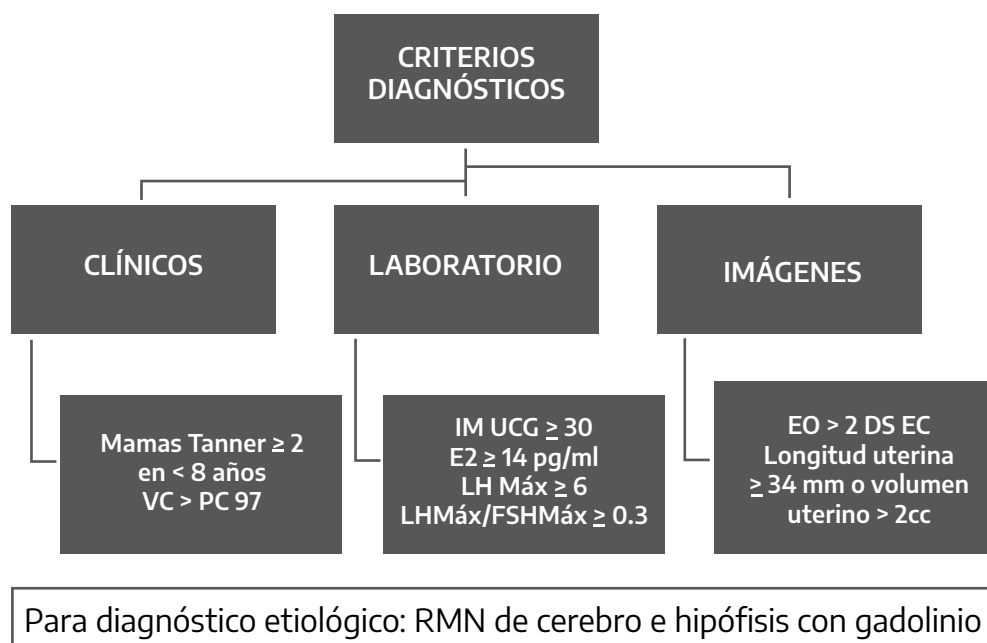
ción estrogénica variable (engrosamiento y palidez de la mucosa himeneal, leucorrea). La evaluación inicial incluye edad ósea (Rx de mano y muñeca izquierda) y ecografía ginecológica. El avance de edad ósea a más de 2 desvíos estándar de la edad cronológica alerta sobre el posible cuadro de PPC. La ecografía ginecológica es de utilidad, donde puede observarse el aumento de la longitud uterina a más de 34 mm, y la presencia de engrosamiento endometrial. En la pubertad la proporción entre cuello/cuerpo uterino pasa de ser 3/1 a ser 1/1 debido al crecimiento del cuerpo. El tamaño de los ovarios es variable, se considera como de características puberales un volumen mayor a 1,2 cm³. La ecografía permite además descartar otras causas de desarrollo sexual precoz como los quistes o masas ováricas. Cuando los niveles séricos de gonadotrofinas se encuentren en rango puberal y sugestivos de PPC, debe solicitarse una resonancia nuclear magnética (RNM) como método de elección para evaluar el SNC. La RMN permite detectar masas intracraneanas u otras lesiones responsables de la PPC, especialmente los hamartomas. Dado que la probabilidad de presentar patología de SNC se reduce con el aumento de la edad, se ha puesto en debate la necesidad de solicitar imágenes de SNC en niñas entre 6 y 8 años. Sin embargo, en los estudios realizado por los autores del presente artículo en la División de Endocrinología del HNRG en un grupo de 70 niñas con PPC entre 7 y 9 años de edad, se detectaron imágenes patológicas en 11,5%, y

en más de la mitad de ellas no existían datos neurológicos que hicieran sospechar estos hallazgos, es recomendable efectuar imágenes del SNC en todas las niñas con diagnóstico de PPC.

En conjunto, la sospecha diagnóstica de pubertad precoz surge por signos clínicos: telarca, signos de estimulación estrogénica vulvar, aceleración de la VC, asociados a progresión de la maduración esquelética (avance de la edad ósea) y agrandamiento uterino y ovárico evaluado por ecografía. Sin embargo, el aporte del laboratorio al diagnóstico de PPC es fundamental dado que permite confirmar la activación del eje H-H-G (dependiente del GnRH hipotalámico) marcando la característica progresiva del cuadro.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL

- ✓ Paciente que presenta signos clínicos de alteración de Eje H-H-G
- ✓ Paciente con VC, con 2,5 DS superior a su edad cronológica
- ✓ Paciente que en los últimos 6 meses ha sido característico y progresivo el cuadro clínico
- ✓ Alteraciones estructurales como Agrandamiento uterino o ovárico seguido por ecografía
- ✓ Alteraciones en los valores de laboratorio
- ✓ Si se observa Masa compatible con tumor en RMN



Comentario de expertos

Dra. Verónica Figueroa Gacitúa

Como bien se comentó, la Pubertad Precoz se define por el inicio puberal antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Es importante destacar en las niñas que no todo inicio de telarca significa inicio puberal. Es por ello que, ante la presencia de telarca en una niña menor de 8 años, hay que derivarla para evaluar la presencia de otros signos puberales y evaluar la progresión o no de los signos y síntomas observados. Generalmente, la pubertad precoz central, tiene una cronología de eventos normal, con inicio de telarca, continuando con aumento de la velocidad de crecimiento y maduración ósea, aumento del tamaño uterino, a expensas de crecimiento del cuerpo uterino y cambios a nivel de la vulva (himen pálido y engrosado, hasta la presencia de flujo estrogénico). Este proceso culmina con la menarca luego de un tiempo promedio de 18 a 30 meses. Cuando la menarca se presenta con poco tiempo de inicio de telarca (o incluso conjuntamente) sin avance del crecimiento, con poco avance de la edad ósea, habría que pensar en causas de pubertad precoz periférica o en causas orgánicas de pubertad precoz central, que pueden tener una evolución más rápida. En ese caso es importante la realización de dosaje de gonadotrofinas y estradiol (para evaluar pubertad precoz dependiente o independiente de gonadotropinas), así como dosaje de marcadores tumorales, realización de imágenes para evaluar presencia de tumores ováricos o suprarrenales y búsqueda de signos asociados al síndrome de McCune Albright (pubertad precoz periférica, manchas café con leche, displasia fibrosa, otros endocrinopatías asociadas).

En el caso de los varones, la probabilidad de que la pubertad precoz tenga una causa orgánica subyacente es más alta, por lo que es fundamental estudiarlos. El inicio de la pubertad en el varón está marcado por el aumento del volumen testicular, el cual se pone de manifiesto en la revisión pediátrica. Cuando se nota el aumento de la velocidad de crecimiento, el aumento de la masa muscular y/o el engrosamiento de la voz, ya la pubertad lleva mucho tiempo de evolución.

Finalmente, es importante tener en cuenta el antecedente de retardo del crecimiento in-

trauterino (RCIU). En el caso de las niñas, se ha asociado un inicio puberal más precoz y una ganancia puberal de talla menor en algunas niñas con antecedente de RCIU, especialmente en las que presentaron una ganancia de peso acelerada en la primera infancia. En los niños con antecedente de RCIU también se ha reportado un inicio puberal más temprano (que puede no acompañarse de un volumen testicular mayor a 4cc, sino que se manifiesta con estímulo androgénico y bioquímicamente) y la ganancia puberal de crecimiento también puede ser menor. Debido a ello, en los niños con antecedente de RCIU, es importante evaluarlos cada 6 meses a partir de los 6-7 años y derivarlos ante el primer signo puberal o en caso de presentar edad ósea adelantada con respecto a la edad cronológica. Un tratamiento precoz de la pubertad precoz, asociado o no a tratamiento con hormona de crecimiento puede mejorar la talla adulta final.

Caso clínico 2

Niño de 14 años que consulta por presentar cefaleas recurrentes y, según referencia materna, “es más pequeño que los demás”.

Situación clínica

Paciente que consulta a los 14.4 años por retardo puberal con talla: 155,4 cm (SDS -0.68), peso: 46,500 Kg (SDS -0.7), velocidad de crecimiento: 2,8 cm/año, Índice de masa corporal: 20,39 (SDS +0.7), testículos 2/2 ml, genitales y vello pubiano en estadio 1 de Tanner. Palidez de mucosas, normotenso. Al interrogatorio surge el antecedente de decaimiento, anorexia, pérdida de peso (25-30 Kg) y cefalea en los últimos 3 años, lo cual obligó a descartar causas generales que pudieran comprometer el crecimiento, la pubertad y el estado general. La rutina general de laboratorio realizada a tal fin fue normal. La edad ósea fue de 13 años. La radiografía de perfil de cráneo mostró una silla turca de forma conservada, pero aumentada de tamaño sin calcificaciones.

Reflexiones

¿Qué planteo diagnóstico tiene? ¿Qué estudio pediría? ¿Estudiaría algo más?, ¿qué interconsulta haría?

Se realiza Interconsulta con endocrinología que

solicita estudios bioquímicos que mostraron niveles séricos disminuidos de gonadotrofinas y testosterona para sexo y edad, niveles séricos de TSH compatibles con hipotiroidismo central, nivel sérico elevado de Prolactina, hipocortisolismo. La respuesta de GH a los estímulos fue insuficiente.

Estos estudios reflejan un estado de Insuficiencia Hipofisaria múltiple. Los niveles elevados de Prolactina orientan a la presencia de una lesión orgánica de la región selar-supraselar con compromiso del tallo hipofisario y afectación concomitante de la secreción de dopamina. En estos casos, los niveles séricos de Prolactina raramente exceden los 150 ng/ml. Niveles séricos mayores orientan al diagnóstico de Prolactinoma. Se solicita Estudio complementarios: La imagen por RMN mostró una lesión expansiva intraselar que ocupa la cisterna supraselar desplazando al quiasma óptico. La imagen presentaba una lesión hiper-intensa en T1 compatible con hemorragia por lo que se planteo como posible diagnostico un Macroadenoma Hipofisario hemorrágico. Sin embargo, los valores de prolactina no fueron compatibles con la posibilidad de Prolactinoma, pudiendo en tal caso corresponder a un Adenoma no funcionante. La evaluación oftalmológica reveló una hemianopsia bitemporal. El paciente inicia tratamiento sustitutivo con Hidrotisona y levotiroxina y es sometido a cirugía para exéresis de la masa tumoral. El diagnóstico anatomopatológico fue Craneofaringioma.

Conclusiones

La pubertad es el período en que se completa la maduración sexual y se alcanza la capacidad reproductora. Durante la pubertad se producen una aceleración del crecimiento y de la edad ósea, y una maduración de los caracteres sexuales primarios (genitales y gónadas) y secundarios (vello pubiano y axilar, desarrollo mamario en la niña y aumento del volumen testicular en el niño).

El inicio de la pubertad viene determinado por un aumento pulsátil de la secreción de la hormona liberadora de hormona luteoestimulante (LHRH), que condiciona un aumento de las gonadotropinas hipofisarias, en especial de la hormona luteoestimulante (LH), que inicia su pulsatilidad nocturna. A su vez, la LH estimula

la secreción gonadal de testosterona y estradiol, siendo ambos esteroides los responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. El mecanismo por el cual se produce la maduración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal es desconocido, aunque parece que en el proceso interviene el sistema nervioso central (SNC), produciendo cambios en la sensibilidad hipotálamica.¹⁸ El primer cambio físico que evidencia el comienzo de la pubertad es la aparición del botón mamario en las niñas y el aumento del volumen testicular (≥ 4 ml) en los niños. En general, la pubertad se inicia en las niñas entre los 10 y 11,6 años, tiene una duración promedio de 2,5 años y finaliza con la aparición de la menarquía, fenómeno que tiene lugar en nuestra población, como promedio, a los 12,5 años. En el niño, la pubertad comienza entre los 11,6 y 12,6 años, y tiene una duración de 3,5-4 años. Las distintas etapas del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en ambos sexos fueron descritas por Tanner, que las dividió en cinco estadios (19) (20).

El retraso en la aparición de los signos puberales ocurre en el 3% de los adolescentes, fundamentalmente del sexo masculino. Se considera que la pubertad es retrasada cuando no se ha producido desarrollo mamario a los 13 años en la niña, o cuando el volumen testicular es inferior a los 4 ml a los 14 años en el niño. El retraso puberal puede producirse por dos tipos de mecanismos: alteración en la puesta en marcha del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (hipogonadismo hipogonadotrófico), o fallo gonadal primario en responder a un eje normalmente funcionante (hipogonadismo hipergonadotrófico). En el primer caso, tanto los valores de gonadotropinas como de hormonas gonadales serán prepuberales; en el segundo caso, valores de gonadotropinas elevados coexistirán con unas cifras de hormonas gonadales bajas. En algunos casos de hipogonadismo hipergonadotrófico, el fenotipo no siempre traduce el genotipo, por lo que en la clasificación etiológica deberá distinguirse entre las causas de retraso puberal con fenotipo masculino o femenino. En la práctica diaria, más del 50% de los casos de retraso puberal en el varón se deberán a un hipogonadismo hipogonadotrófico transitorio, sin enfermedad asociada, constituyendo el cuadro denominado retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD), mientras que en la niña, hasta el 30%

de los casos pueden deberse a cromosomopatías (el síndrome de Turner es el más frecuente).

Evaluación del paciente con pubertad retrasada

1. Clínica

Es importante recoger las tallas y patrones puberales de los padres, ya que en los casos de RCCD, suele existir una historia familiar de retraso puberal. La anamnesis orientará hacia la existencia de enfermedades crónicas, tipo de régimen alimentario, práctica de ejercicio físico intenso, irradiaciones o tratamientos inmunosupresores. En la mayoría de los casos de RCCD, el examen físico pone en evidencia una talla baja. Si además existe una talla baja familiar, el retraso puberal puede exacerbar el retraso de crecimiento, y en ocasiones se debe establecer el diagnóstico diferencial con el déficit de hormona de crecimiento (GH). Hay que valorar la existencia de signos puberales incipientes que pueden haber pasado desapercibidos, sobre todo de un discreto aumento del volumen testicular. La existencia de proporciones corporales eunucoides hará sospechar un síndrome de Klinefelter o un déficit aislado de gonadotropinas. En las niñas, hay que recordar que el síndrome de Turner no siempre se acompaña de los estigmas típicos, y en ocasiones la talla baja (o situada en un percentil inferior a la talla genética) y la ausencia de signos puberales son los únicos signos presentes. Algunas pacientes presentan una pubertad espontánea sin menarquia. La amenorrea primaria después de 4 años de haberse iniciado la pubertad, sobre todo si se asocia a talla baja, debe hacer sospechar esta entidad.

En otros casos, la talla puede ser adecuada a la edad cronológica, o incluso alta (anorquia, déficit aislado de gonadotropinas, síndrome de Klinefelter), o puede existir un déficit ponderal en relación a la talla (celiaquía, anorexia nerviosa). El déficit aislado de gonadotropinas es más frecuente en el varón. Cuando se asocia a anosmia constituye el cuadro clínico conocido como síndrome de Kallmann, que se caracteriza por una agenesia o hipoplasia de los lóbulos olfatorios, asociada a un fallo en la migración de las neuronas secretoras de LHRH y olfatorias hacia el hipotálamo. Dicha migración depende de una molécula guía, la proteína KAL, codificada por el

gen KAL. En las formas familiares de síndrome de Kallmann (ligadas al cromosoma X) se han descrito diversas mutaciones en el gen KAL, que determinarían la producción de una proteína no funcionante o la ausencia de la misma. El hipogonadismo hipogonadotrófico aislado (sin anosmia) suele ser esporádico, o de herencia autosómica recesiva. La delección de los exones 2 a 4 que caracteriza al ratón hipogonadal con esta entidad no se ha observado en humanos. Recientemente, en algunos casos de hipogonadismo hipogonadotrófico de carácter familiar se han encontrado mutaciones en el gen del receptor de la LHRH. En el varón, la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrófico es el síndrome de Klinefelter.

El diagnóstico se realiza pocas veces antes de la pubertad, salvo en los casos asociados a criptorquidia bilateral o micropene. Muchos de estos pacientes presentan un desarrollo puberal espontáneo y alcanzan un volumen testicular entre 4 y 6 ml, con una longitud del pene normal. Sin embargo, la pubertad no progresa adecuadamente, lo que debe hacer sospechar esta entidad. En la mujer, la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrófico es el síndrome de Turner. (22)

2. Exploraciones complementarias

Inicialmente se debe realizar una valoración de la edad ósea, una analítica general, incluyendo anticuerpos anti gliadina y anti endomisio, y determinar las cifras de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-I), gonadotropinas y esteroides gonadales. El cariotipo en sangre periférica es diagnóstico en el síndrome de Turner y Klinefelter. El examen de fondo de ojo y las técnicas de imagen, como la resonancia nuclear magnética, son útiles en el diagnóstico etiológico del hipogonadismo hipogonadotrófico permanente. En el RCCD, la edad ósea está retrasada y la talla es adecuada para el grado de maduración esquelética. Los signos clínicos de pubertad empiezan a una edad ósea aproximada de 11 años en las niñas y de 12 años en los niños; por lo tanto, una edad ósea superior a los 12-13 años en ausencia de pubertad es sugestiva de enfermedad. Algunos autores han apuntado que el RCCD se acompaña de una disminución de la mineralización ósea; sin embargo, estudios recientes parecen demostrar que la densidad mineral ósea volumétrica en estos pacientes es

normal, por lo que no consideramos necesaria su valoración sistemática.

3. Determinaciones hormonales

El inicio de la pubertad viene definido por la aparición de picos pulsátiles de LH, que en un principio son sólo nocturnos, manteniéndose los valores basales y diurnos prepuberales. Posteriormente aumentan los picos de secreción en frecuencia y amplitud. Para constatar el inicio de la pubertad, puede realizarse el estudio de la secreción integrada de LH nocturna o un test funcional farmacológico que estimule la secreción de gonadotropinas hipofisarias y/o de los esteroides gonadales. Las determinaciones basales de LH, hormona foliculoestimulante (FSH), estradiol y testosterona no suelen ser informativas al inicio de la pubertad, ya que los valores prepuberales se encuentran en el límite de significación de los métodos de cuantificación, por lo que un ligero aumento es en general inapreciable. Para algunos parámetros, como el estradiol o las gonadotropinas, existen metodologías que alcanzan sensibilidad suficiente como para detectar valores prepuberales aunque dichos métodos no están al alcance de todos los laboratorios. La determinación de testosterona en saliva de primera hora de la mañana se ha considerado predictiva del inicio de la pubertad; sin embargo, este parámetro tiene una sensibilidad limitada. Para obviar dicho problema, se realizan actualmente tests funcionales de estimulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, que son capaces de diferenciar el RCCD de un hipogonadismo hipogonadotrófico permanente. La administración de LHRH nativo (100 µg por vía intravenosa) permite evaluar solamente la respuesta hipofisaria, que no es siempre discriminativa. En caso de pubertad evolutiva, la respuesta máxima de LH es superior o igual a 8-10 IU/l. La administración de una dosis única de un análogo de la LHRH (acetato de leuprolide, 500 µg s.c., o nafarelina 100 µg s.c.) permite la exploración simultánea de la hipófisis y de la gónada. La respuesta máxima de las gonadotropinas se produce unas 3 h después de administrar el análogo, mientras que el pico máximo de secreción gonadal se detecta entre las 18-24 hs. En el test de estimulación con acetato de leuprolide, se considera que la respuesta es puberal cuando la LH es superior o igual a 10 IU/l a las 3 h, la testosterona es igual o superior a 3,15

nmol/l (90,7 ng/dl) y la respuesta del estradiol igual o superior a 150 pmol/l (40,8 pg/ml) a las 24 h de administrar el análogo. La respuesta de gonadotropinas y esteroides gonadales en cada uno de los estadios puberales ha sido recientemente estandarizada. (23)

Tratamiento

En el RCCD la actitud terapéutica dependerá de si el sujeto está o no psicológicamente afectado por su retraso puberal. Si existe una historia familiar clara, suelen bastar un seguimiento sin tratamiento y una reevaluación de la situación clínica y analítica a los 6 meses. Si existen inadecuación social o problemas de autoestima, se aconseja la administración de tandas cortas de enantato de testosterona depósito a partir de los 14 años; 50 mg/mes por vía intramuscular. Dichas dosis inducen el brote puberal sin afectar la talla adulta ni el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La administración de undecanoato de testosterona oral (dosis inicial de 40 mg/día) es considerada por algunos autores una buena alternativa al tratamiento parenteral, aunque las dosis óptimas no están bien definidas. En las chicas, se administra etinil estradiol a partir de los 13 años de edad (2,5-5 µg/día por vía oral), o estrógenos conjugados (0,3 mg/día, por vía oral) durante 3-6 meses. El tratamiento se mantiene durante unos 6 meses, reevaluándose tras este período el estado auxológico y hormonal. Si a los 3-6 meses de suspender el tratamiento no empieza la pubertad espontánea o no aumentan las cifras de esteroides gonadales, puede administrarse un segundo ciclo de tratamiento. La utilización de esteroides anabólicos del tipo de la oxandrolona (0,05-0,07 mg/kg/día por vía oral), en pacientes con talla baja y un gran retardo madurativo, no tiene, según nuestra experiencia, ventajas con respecto al tratamiento anterior, aunque no existe consenso al respecto. El tratamiento con esteroides sexuales es el mismo en el hipogonadismo hiper e hipogonadotrófico permanente, aunque en el primero constituye la única opción terapéutica. En el varón, el enantato de testosterona depot por vía intramuscular es el producto más utilizado. Las dosis recomendadas son de 50 mg/mes durante 6 meses, seguida de 100 mg/mes durante un año, continuando con 250 mg al mes. El tratamiento se debe iniciar cuando la edad

ósea es de unos 12,5 años. En el sexo femenino, se utiliza el etinil estradiol, a razón de 2,5-5 μ g/día, o 0,3 mg/día de estrógenos conjugados, por vía oral, a dosis crecientes, hasta alcanzar los 10 μ g/día o los 1,25 mg/día en un plazo de 18-24 meses, momento en el cual debe asociarse un progestágeno sintético (acetato de medroxi-progesterona, 5-10 mg/día), e iniciar una terapia cíclica, para disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial y de adenocarcinoma, e iniciar las menstruaciones. Se recomienda inducir la pubertad a una edad ósea aproximada de 11 años, aunque debe individualizarse cada caso.

En el síndrome de Turner, se recomienda la administración de estrógenos por vía transdérmica una vez alcanzada la talla definitiva. Las dosis recomendadas son de 100 μ g cada tres días (lo que supone una dosis diaria mínima de unos 25 μ g), a las que se añaden 0,3 mg/día de noretisterona 10 días cada 4 semanas para conseguir una hemorragia cíclica. Este procedimiento parece ser más fisiológico que la administración oral, ya que el compuesto pasa a través de la piel a la circulación general y a los receptores mamarios, evitando el sistema hepático. Recientemente, se ha demostrado la eficacia del 17 β -estradiol en forma de vaporizador nasal, aunque las dosis óptimas están aún por determinar. El tratamiento con gonadotropina coriónica humana (hCG), que aporta LH, y gonadotropina menopáusica humana (hMG), que aporta FSH, se utiliza para inducir la espermatogénesis en el varón y la ovulación en la mujer en pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico. Aunque también puede inducir el desarrollo puberal, al igual que la LHRH pulsátil, se restringen habitualmente para la consecución de fertilidad. El efecto secundario más notorio del tratamiento con gonadotropinas es la ginecomastia, que parece estar causada por un exceso de estrógenos provenientes de las células de Leydig en respuesta a la hCG. La inducción de la fertilidad en ambos sexos se realiza mediante minibombas de infusión de LHRH pulsátil. En el varón, el tratamiento con LHRH pulsátil determina un crecimiento testicular más rápido y la espermatogénesis, además de disminuir la incidencia de ginecomastia; en la mujer, supone un menor riesgo de hiperestimulación ovárica. (21)

Comentario de Experta

Dra. Laura Diana Milgram

Una de las principales características de la pubertad es su variabilidad. El comienzo, el ritmo y la magnitud de los cambios puberales están sometidos de manera importante a la influencia de factores genéticos, hormonales y ambientales. Lo que se mantiene habitualmente en la pubertad estable es la secuencia y la cronología de los cambios.

En las niñas la aparición del botón mamario o telarca marca el inicio de la pubertad, suele tener lugar entre los 8 y los 13 años. En los varones el primer cambio puberal es el aumento del tamaño testicular esto suele ocurrir entre los 9 y los 14 años.

Pubertad precoz se define como la aparición de los caracteres sexuales secundarios en una edad cronológica inferior a la media de la población. Es decir aquellos casos en que los cambios puberales ocurren antes de los ocho años.

Se denomina pubertad retrasada o detención del desarrollo en las mujeres si presenta algunas de las siguientes características:

- Es mayor de 13 años y aún no tiene características sexuales secundarias.
- Es mayor de 16 años y aún no ha tenido su menarca.
- Presenta más de cinco años desde el inicio de la telarca y no ha tenido su menarca.

Se denomina pubertad retrasada cuando un varón no presenta cambios puberales a los 14 años.

En este trabajo se describen muy bien dos casos de pubertad patológica. Tanto la pubertad precoz como la tardía merecen un exhaustivo estudio a fines de determinar etiología, realizar el tratamiento adecuado y evitar secuelas.

Referencias bibliográficas

-
1. Sørensen K1, Mouritsen A, Aksglaede L, et al. Recent secular trends in pubertal timing: implications for evaluation and diagnosis of precocious puberty. *Horm Res Paediatr* 2012;77(3):137-45.
 2. Buck Louis GM1, Gray LE Jr, Marcus M, et al. Environmental factors and puberty timing: expert panel research needs. *Pediatrics* 2008;121(Suppl 3):S192-207.
 3. Del Pino M, Bay L, Lejarraga H, et al. Peso y estatura de una muestra nacional de 1971 adolescentes de 10 a 19 años: las referencias argentinas continúan vigentes. *Arch Arg Pediatr* 2005;103:323-30.

4. Lejarraaga H, Cusminsky M, Castro EP. Age of onset of puberty in urban argentinian girls. *Ann Hum Biol* 1980;7(6):579-81.
5. Ibáñez L1, Dimartino-Nardi J, Potau N, et al. Premature adrenarche--normal variant or forerunner of adult disease? *Endocr Rev* 2000;21(6):671-96.
6. Gryngarten M, Escobar ME, Campo S, et al. Detección de la deficiencia de 21 hidroxilasa en su forma Desarrollo sexual precoz en niñas *Rev. Hosp. Niños (B. Aires)* 2018;60(270):244-249 I 249 no clásica en una población argentina de 100 niñas con pubarca precoz. *Endocrinología* 1998;45(suppl 1):25-30.
7. Ibáñez L, Virdis R, Potau N, et al. Natural history of premature pubarche: an auxological study. *J Clin Endocrinol Metab* 1992;74(2):254-7.
8. Neville KA, Walker JL. Precocious pubarche is associated with SGA, prematurity, weight gain, and obesity. *Arch Dis Child* 2005;90(3):258-61.
9. Ibáñez L, Jiménez R, de Zegher F. Early puberty-menarche after precocious pubarche: relation to prenatal growth. *Pediatrics* 2006;117(1):117-21.
10. Ibáñez L, de Zegher F, Potau N. Premature pubarche, ovarian hyperandrogenism, hyperinsulinism and the polycystic ovary syndrome: from a complex constellation to a simple sequence of prenatal onset. *J Endocrinol Invest* 1998;21(9):558-66.
11. Gryngarten M, Escobar ME, Keselman A, et al. Evolución a largo plazo de niñas con pubarca precoz. *Rev Hosp Niños (B. Aires)* 2003;45:69-74.
12. Escobar ME, Gryngarten M, Ballerini MG, et al. High prevalence of hyperandrogenism in adolescents with history of premature pubarche. *Horm Res* 2005;(suppl 1):208.
13. Chellakooty M1, Schmidt IM, Haavisto AM, et al. Inhibin A, inhibin B, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol, and sex hormonebinding globulin levels in 473 healthy infant girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88(8):3515-20.
14. Partsch CJ, Sippell WG. Pathogenesis and epidemiology of precocious puberty. Effects of exogenous oestrogens. *Hum Reprod Update* 2001;7(3):292-302.
15. Madhavapeddi R, Ramachandran P. Side effects of oral contraceptive use in lactating women – enlargement of breast in a breast-fed child. *Contraception*. 1985;32:437-43.
16. Wilkins L, en *Diagnosis and treatment of endocrine disorders of childhood and adolescence*. Springfield- Illinois Charles C Thomas. Ed 3ª. 1965.p.206.
17. Escobar ME, Gryngarten M, Ropelato MG, et al. Desarrollo mamario prematuro: etiología y evolución. *Rev Hosp Niños (B. Aires)* 2003;45:62-8.
18. Terasawa E. Hypothalamic mechanism of the onset of puberty. *Curr Opin Endocrinol Diabet*, 6 (1999), pp. 44-49
19. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in girls.. *Arch Dis Child*, 44 (1969), pp. 291-303
20. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. *Arch Dis Child*, 45 (1970), pp. 13-23
21. Cañete Estrada R, Mata Rodríguez C, Aguilar Quintero M, Retraso puberal. Hipogonadismos. *Protoc diagn ter pediatri*. 2011;1:205-17
22. Boquete H.R., Martínez Alicia, Jasper H. retraso puberal en el varón. Vol 41 Nro 2 2004
23. Sequera, A.M.; Fideleff H.F; Boquete, H.R. y col. Basal Ultrasensitive LH assay: A Useful tool in the Early Diagnosis of Male Pubertal Delay. *J Pediatric endocrinol Metab* 2002; 15: 589-596

***Dra. Verónica Figueroa Gacitúa**

Pediatra, Endocrinóloga infantil del Hospital de Niños
Dr. Pedro de Elizalde

****Dra. Laura Diana Milgram**

Pediatra, Jefa de Servicio de Adolescencia del Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez CABA

MATERNIDAD ADOLESCENTE: RETOS ACTUALES EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA

Hospital Zonal de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata.
Residencia de Pediatría



Dra. Analía Arturi

Jefa de Servicio

Dra. Marta Vinuesa

Instructora de Residentes

Dra. Rocío Ligo

Jefa de Residentes

Dra. Cecilia de la Vega

Residente

Dra. Florencia Menegazzo

Ex Jefa de Residentes

Dra. María Teresa Domínguez*

Revisora

Sumario

Para el abordaje del embarazo en la adolescencia temprana (cuando este es un hecho), el primer punto es la DETECCIÓN OPORTUNA para el asesoramiento integral en la toma de decisiones. Trabajar en la prevención del embarazo en la adolescencia en forma integrada desde todos los accesos al sistema de salud es de fundamental importancia

Situación clínica

Tamara de 14 años consulta por guardia por dolor abdominal, viene acompañada por su madre pero pide ingresar sola a la consulta.

Tiene un embarazo avanzado que refiere haber ocultado a su familia y en la escuela.

HISTORIA CLÍNICA

Es asistida por una obstetra quien realiza la anamnesis y le da un espacio para que hable. Tamara refiere estar en pareja con Diego; un

compañero de colegio de 15 años de edad desde hace 1 año. Cuenta que recibió escasa información sobre educación sexual, y le dio vergüenza preguntar.

Comenzaron hace un tiempo a tener relaciones sexuales, ella creía que si no lo hacía, él la iba a dejar. Recurrió al hospital para asesoramiento en anticoncepción, donde le dijeron que debía sacar un turno y venir acompañada por su madre, por lo cual no regresó.

Antecedentes familiares: vive con sus padres y 4 hermanos. Ella se encarga del cuidado de los mismos mientras sus padres trabajan.

No concurre a la escuela desde hace 3 meses.

Antecedentes personales: no registra de importancia. Menarca 12 años, ritmo menstrual normal. IRS (inicio relaciones sexuales) 13 años. No utiliza métodos anticonceptivos.

EXAMEN FÍSICO

Buen estado general

Signos vitales: FC 98 lpm, FR 18 rpm, TA 110/70

mm Hg, P: 54 kg T 157 cm altura uterina 29 cm (aproximadamente 34 semanas EG),

FUM: incierta. Resto de examen físico sin particularidades.

Se cita para control, se solicitan laboratorio y ecografía

SITUACIÓN ACTUAL

Concurre a la semana de la primera consulta presentando amenaza de parto pretérmino con cuadro compatible con preeclampsia, se realiza cesárea de urgencia.

Nace RNPT 34 semanas con peso de nacimiento de 1,800 kg, Apgar 9/10, e ingresa a UCIN.

La evolución clínica de la madre y del niño es favorable. Concurre a los informes acompañada por Diego y su madre.

Tamara refiere estar triste y se niega a amamantar.

Se realiza asesoramiento sobre métodos anticonceptivos. Tamara elige implante subdérmico.

En la evolución ha implementado la lactancia exclusiva y ha cumplido con los controles de su bebe

REFLEXIONES

1) ¿Recibió este caso educación sexual? ¿Fue asesorada acerca de uso de métodos anticonceptivos?, ¿Encontró barreras de acceso a las mismas?

2) ¿Detecta factores de riesgo?

3) ¿Detecta factores protectores?

4) ¿Detecta indicios de violencia de género, abuso sexual, violación?

5) ¿Reconoce problemas comunes a la situación de embarazo adolescente en Argentina?

6) ¿Qué riesgos para la salud materno infantil presenta el caso de Tamara?

7) ¿Qué riesgos a largo plazo puede suponer la maternidad temprana?

ACTUALIZACIÓN

La ocurrencia de un embarazo antes de la maduración física, mental y social tiene consecuencias de corto y largo plazo que afectan el derecho a una niñez y adolescencia sanas, comprometiendo las etapas posteriores del ciclo vital.

SITUACIÓN DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA ARGENTINA (1)

- ✓ Alrededor del 14% de los nacimientos son

hijos de madres menores de 20 años.

- ✓ 1 de cada 4 adolescentes ya habían tenido al menos un hijo
- ✓ En Chaco, Formosa y Misiones, 1 de cada 5 nacimientos corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.
- ✓ 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años son no intencionales.
- ✓ 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría son consecuencia de abuso sexual y violación.
- ✓ En Argentina, cada 6 minutos una adolescente tiene un hijo/a por día
- ✓ Nacen 7 bebés por día de niñas menores de 15 años

CAUSAS DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

- ✓ Abuso sexual
- ✓ Violencia de género
- ✓ Falta de educación sexual y acceso de los métodos anticonceptivos
- ✓ Ausencia de proyecto personal



Fuente: www.sap.org.ar/comunidad-novedad.php

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA (2)

- ✓ Afectación de la salud, el bienestar y las oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo personal.
- ✓ Se profundizan las desigualdades de género.
- ✓ Abandono Escolar: el 30 % de las jóvenes que abandonaron el secundario, lo hicieron por embarazo y maternidad
- ✓ Barreras de inserción laboral: las que son madres, tiene una mayor probabilidad de estar inactivas laboralmente (56 % vs 44 %)
- ✓ Riesgos para la salud en las menores de 15 años.
- ✓ Si el embarazo se produce por un abuso sexual o violación, se afecta gravemente la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes

Convención de los Derechos de NNyA			
Interés Superior del Niño	Autonomía Progresiva	Participación directa	Principio de Igualdad Y no Discriminación
Es "la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos."	Proceso en el que se consolida progresivamente la capacidad de discernimiento.	Ser oído cualquiera sea su edad.	Tomar medidas para garantizar igualdad de oportunidades
Es el cumplimiento pleno y efectivo de sus derechos.	Todas las personas son capaces y pueden ejercer sus derechos de forma directa, pero algunas requieren un acompañamiento (asistencia) adecuado a su capacidad de discernimiento individual.	Que su opinión sea tomada en cuenta.	Remover estructuras de poder que impidan a NNyA ejercer sus derechos

Artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación Resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación

Derecho a la decidir sobre el cuidado del propio cuerpo. Artículo 26 del CCyC	
Niños/as hasta 13 años	Brindan su consentimiento con la asistencia de un adulto referente. Considerar siempre el Interés Superior del Niño y la Autonomía Progresiva
Adolescentes de 13 a 16 años	Tienen aptitud para decidir siempre que las practicas no impliquen riesgo grave para su vida o la salud (prácticas no invasivas).
Adolescentes a partir de 16 años	Tienen capacidad plena como las personas adultas

Convención sobre los derechos del niño Asamblea General de las Naciones Unidas 1989

ROL DE LOS EQUIPOS DE SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

- ✓ Garantizar el cumplimiento y la protección de los Derechos de NNyA.
- ✓ Dar herramientas para que puedan tomar decisiones libres e informadas.
- ✓ Acceso efectivo a los Métodos Anticonceptivos. A las consultas acerca de anticoncepción se les debe dar resolución urgente.
- ✓ La prescripción de métodos anticonceptivos, de barrera, hormonales, de larga duración y la anticoncepción de emergencia, debe hacerse cada vez que sean solicitados por el adolescente, sin ningún otro requisito más que su consentimiento y su evaluación integral de salud
- ✓ Abordaje del Abuso Sexual. Cuando el embarazo ocurre en menores de 15 años debe pesquisarse la presencia de relaciones de poder/abuso
- ✓ Acceso al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo cuando es requerido
- ✓ Garantizar la respuesta a la consulta precoz y la adherencia a los controles prenatales
- ✓ Fomentar el acompañamiento durante el trabajo de parto y parto
- ✓ Asesorar y proveer métodos anticonceptivos post parto
- ✓ Fomentar la lactancia y los controles de salud del recién nacido

Incidencia de embarazo en adolescentes menores de 15 años desde enero de 2016 a diciembre de 2018 en una maternidad de Hospital Zonal General de La Plata

(Trabajo realizado en el Servicio del Hospital, que muestra aspectos epidemiológicos locales)

Objetivos Generales

Evaluar la incidencia de embarazo en la mujer adolescente menor de 15 años durante enero de 2016 a diciembre de 2018 en la maternidad del HGZA Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata

Objetivos específicos

- ✓ *De la mamá adolescente*
Analizar la incidencia de embarazos y naci-

mientos en adolescentes menores de 15 años

✓ *Del hijo*

Características de los recién nacidos

Cumplimiento del control de salud del RN

Material y métodos

Estudio analítico de corte transversal con datos obtenidos de las historias clínicas, de Sistema Informático Perinatal (SIP) OMS.

Población: Mujeres con embarazo, menores de 15 años que acceden al Sistema Público de Salud de la ciudad de La Plata desde enero 2016 a diciembre 2018

Criterios de inclusión: madres adolescentes que dieron a luz en HZGA Dr. Ricardo Gutiérrez, y permanecieron internadas en el puerperio inmediato en alojamiento conjunto con su hijo.

Variables analizadas

- Edad materna:
 - 12 años
 - 13 años
 - 14 años
- Embarazo planeado: (Gráfico 1)
 - Sí
 - No
- Utilización de métodos anticonceptivos. Cualitativo (Gráfico 2)
 - No usaba
 - De barrera
 - Hormonal
 - ASI
- Control de Embarazo. (Gráfico 3)
 - En centro de salud 1er nivel de Atención
 - En hospital 2do nivel de atención
- Acompañante en Trabajo de parto, Acompañante en parto. (Gráfico 4)
 - Familiar
 - Personal de Salud
 - Pareja
- Vía de finalización (Gráfico 5)
- Parto eutócico
- Cesárea
- Características del RN
 - RNT
 - RNPT
 - Patología perinatal presentada
- Seguimiento del Recién nacido
 - Control de salud en consultorio de niño sano
 - Control en consultorio de RN de alto riesgo

RESULTADOS

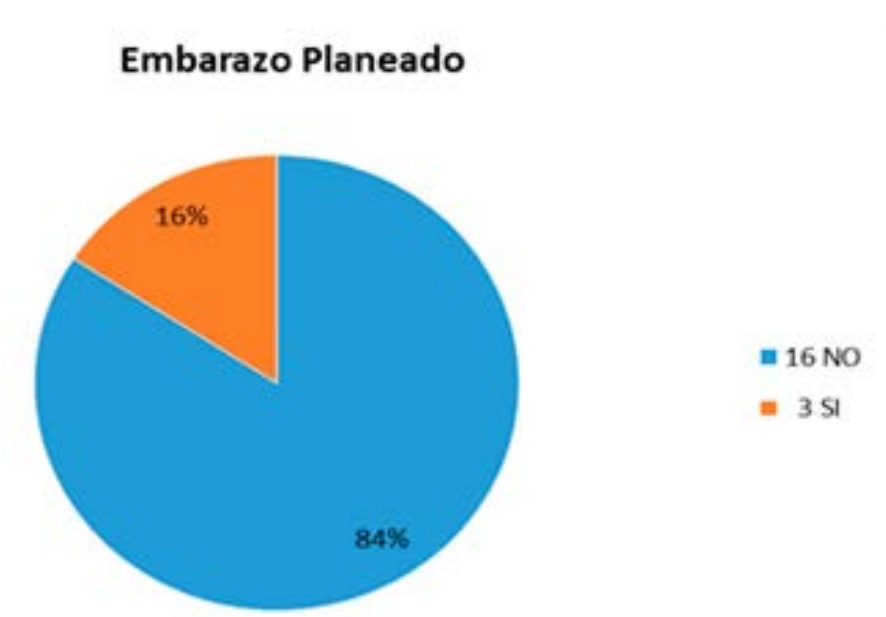


Gráfico 1



Gráfico 2

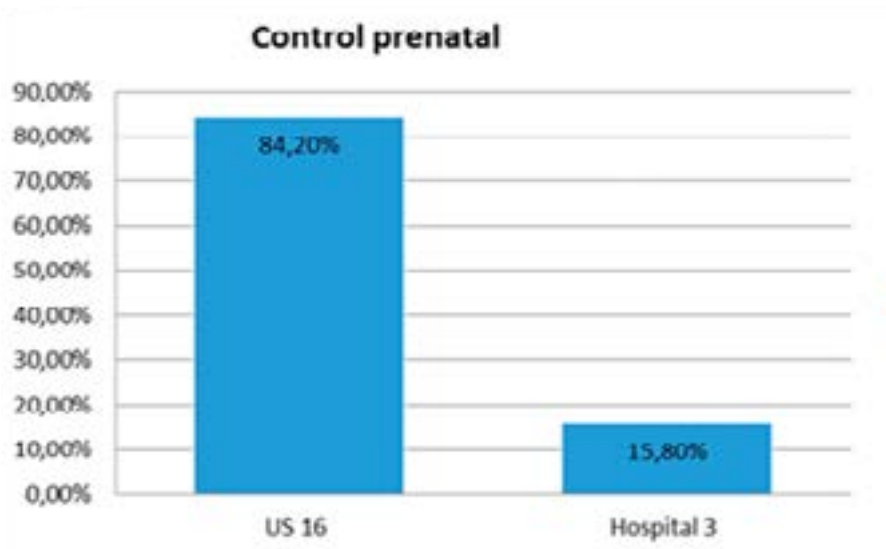


Gráfico 3



Gráfico 4



Gráfico 5

CONCLUSIONES

- ✓ La incidencia de nacimientos en menores de 15 años es baja con respecto al total
- ✓ Según las variables analizadas, el 53% (n=10) no usó ningún método anticonceptivo
- ✓ El 84 % (n=16) de las adolescentes no había planificado el embarazo
- ✓ En relación al control del embarazo observamos que el 84,2% (n=16) lo cumplió en el 1er nivel de Atención, 15,8% (n=3) lo realizó en el 2do nivel con un abordaje interdisciplinario y acompañamiento continuo con servicio social, salud mental y clínica de adolescentes
- ✓ El 63% fue acompañada durante el trabajo de parto y parto por personal de salud
- ✓ El 57% (n=11) del total nacieron por parto eutócico y 42,1% (n=8) por cesárea. La mayoría de los embarazos llegaron a término

- ✓ Solo 15,8% (n=3) cumplieron con el control y seguimiento del recién nacido durante el 1er año de vida

Comentario de Experta Dra. María Teresa Domínguez

Para el abordaje del embarazo en la adolescencia temprana (cuando este es un hecho), el primer punto es la DETECCIÓN OPORTUNA para el asesoramiento integral en la toma de decisiones.

Trabajar en la prevención del embarazo en la adolescencia en forma integrada desde todos los accesos al sistema de salud es de fundamental importancia.

Se debe permanecer alerta en la detección de abuso y violencia de género y su manejo adecuado.

Es prioridad mejorar la referencia/contratransferencia con el centro de atención primaria de

nuestra población objetivo. No sólo requieren de atención médica, sino también de acompañamiento y contención emocional, para poder brindar asistencia diferenciada con un enfoque interdisciplinario.

Debemos pensar que las consecuencias del embarazo adolescente tienen amplio impacto a lo largo de la vida y de las generaciones subsiguientes.

Referencias Bibliográficas

1. *Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadística e Información de Salud. 2017. Sistema Informático Perinatal (SIP) Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2015*
2. *Ministerio de Salud de la Nación. Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia Ministerio de Salud de la Nación 2017-2019*
3. *Artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación*
4. *Resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación*
5. *Ministerio de Salud de la Nación "Protocolo para la atención de personas víctimas de violencia sexual" Ministerio de Salud de la Nación (2011)*
6. *Asamblea General de las Naciones Unidas Convención sobre los derechos del niño 1989*
7. *Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia Septiembre 2019*
8. *Programa Nacional de Actualización Pediátrica. Anticoncepción en las adolescentes y los adolescentes Módulo 4 Capítulo 3 Pag 55-103 (PRONAP 2011)*
9. *Ministerio de Salud de la Nación. Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo Actualización 2019 Resolución 1/2019*

*Dra. María Teresa Domínguez

Jefa de Unidad de Adolescencia del Hospital Dr. R. Gutiérrez de La Plata.

Docente de la Cátedra de Pediatría A UNLP.

ABUSO, MALTRATO Y NEGLIGENCIA INFANTIL

**Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Alberto Eurnekian” de Ezeiza.
Servicio de Pediatría e Internación. Residencia de Clínica Pediátrica**



Dra. Alejandra Leguizamo

Instructora de Residentes

Dr. Pablo Gallardo

Jefe de Residentes

Dra. Érica B. Cruz Galian

Dra. Lucia Cárdenas

Dra. Giselle Molina

Dra. Claire Delgadillo

Dr. Eric Berestein

Revisor

Dra. María Del Rosario Mesiano*

Revisora

Sumario

En nuestro sistema penal argentino el abuso sexual está tipificado y es reprimido con prisión o reclusión cuando la víctima fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

Crudo análisis de una situación frecuente.

Situación Clínica

Paciente de sexo masculino de 3 años de edad, ingresa a la guardia externa junto a su madre,

por presentar elemento introducido en el ano (aguja de tejer). Según refiere la madre, fue encontrado en la cama de su habitación por un familiar, y consultan inmediatamente

Historia Clínica

Antecedentes perinatólogicos: madre niega.

Antecedentes patológicos: bajo peso / baja talla. Vacunas incompletas para la edad, sin controles de Pediátricos.

Antecedentes familiares: oriundos de Bolivia, al año de vida del paciente emigran a la Argentina, madre víctima de violencia de género por el padre del niño.

Actualmente viven en una habitación junto a su pareja.

Examen Físico

Paciente ingresa clínicamente estable y hemodinámicamente compensado, afebril, normotenso, normohidratado, en suficiencia cardiorespiratoria. Presenta elemento introducido en el ano. A nivel de planta de pie izquierdo impresiona cicatriz por quemadura. No presenta sangrados ni hematomas en el resto del cuerpo.



Reflexiones

- ¿Abuso sexual es sinónimo de violación?
- ¿Existen indicadores predictores para sospechar de SMI, ASI o Negligencia?
- ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de SMI, mayor frecuencia?
- ¿Qué estudios debemos solicitar frente a un caso de SMI?
- ¿Cómo actuar frente a una sospecha de ASI?

Comentario

El caso presentado corresponde a Maltrato infantil, Negligencia y Abuso sexual.

Se puede clasificar al Maltrato infantil en: Maltrato físico, Negligencia y Abuso Sexual.

Se considera Maltrato Infantil (MI) a toda acción u omisión cometida por personas, instituciones o la sociedad en su conjunto que ponga en peligro la salud física o mental del niño o adolescente, lo priven tanto de su libertad como de sus derechos o dificulten su óptimo desarrollo. Cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños y los adolescen-

tes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que acción, omisión o negligencia no accidental que prive al infante o adolescente de sus derechos y su bienestar, provocando desarrollo físico, psíquico o social.

El Abuso Sexual Infantil (ASI) es la intervención de un niño en actividades sexuales que no corresponden a su etapa evolutiva, es emocionalmente inmaduro y dependiente para comprenderlas, y no está capacitado para dar su consentimiento. Las acciones abusivas no necesariamente implican contacto físico. Pueden ser comentarios sexualizados, exhibición de genitales, voyeurismo, exhibición de materiales pornográficos, inducción a que la persona se desnude o masturbe. Las acciones abusivas pueden implicar contacto sexual sin penetración. Pueden ser manoseo en las partes íntimas (genitales, glúteos, pechos), inducción a tocar al agresor, frotación de los genitales del agresor contra el cuerpo de la persona agredida.

La violación es un evento inesperado, único, violento e impredecible, que se define como el acceso carnal (vaginal, anal o bucofaríngea) por medio de la fuerza o de amenazas sin consentimiento de la otra persona. Suele producir lesiones físicas y puede, a veces, poner en peligro la vida del agredido.

La Negligencia infantil puede abarcar negligencia Física (no proveer alimentos, vestido o vivienda y otras necesidades físicas); Emocional (no proveer amor, comodidad o afecto) o Médica (no proveer atención necesaria).

Epidemiología

- ✓ Se estima que 6 de cada 10 niños en el mundo de entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario (1.000 millones de niños que padecen maltrato de parte de sus cuidadores).
- ✓ Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos cuando eran niños.
- ✓ 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia

¿Existen indicadores predictores para sospechar de SMI, ASI o Negligencia?

Como Pediatras debemos conocer los indicadores generales de SMI:

Maltrato Infantil

Magulladuras, Hematomas, quemaduras, fracturas, heridas, falta de cabello. Accidentes frecuentes. Cautela o rechazo al contacto físico. Sometimiento ante pares y adultos. Aprensión ante el llanto de otros niños. Conductas no “esperables”. Falta de pelo. Temor a sus padres. Ropa inapropiada. Inestabilidad emocional. Trastorno del lenguaje: tartamudeo, mutismo. Tristeza, ansiedad, depresión. Encopresis/enuresis. Inquietud, rigidez. Sentimiento de culpa. Aislamiento. Baja autoestima.

Abuso Sexual

Embarazo, Indicios de actividades sexuales. Lesiones en zonas genital y/o anal: Diámetro del himen mayor 1 cm, o Dilatación anal > 15 mm, esfínter anal hipotónico. Juegos sexuales inadecuados con niños o juguetes o sus propios cuerpos. Conductas sexuales agresivas hacia terceros. Enfermedades de transmisión sexual. Comprensión detallada de conductas sexuales no acorde a la edad. Contusión o sangrado anal o vaginal que no puedan ser explicados. Temor exacerbado a los hombres. Semen en la ropa o el cuerpo, Masturbación compulsiva conductas sexuales agresivas hacia terceros. Comprensión detallada de conductas sexuales no acorde a la edad.

Negligencia

Falta de higiene. Apatía. Malnutrición, retraso en el crecimiento. Baja autoestima. Falta de supervisión del adulto. Falta de empatía. Necesidades médicas y odontológicas no atendidas. Relaciones de dependencia o desconfianza. Lastimaduras por falta de cuidado. Ropa inadecuada. Sentimiento de soledad en el hogar. Participación en actividades impropias de la edad. Falta de empatía. Largos períodos de tiempo solo en el hogar. Relaciones de dependencia o desconfianza. Permanencia prolongada en la calle. Tristeza y ansiedad persistente. Comportamiento apático. Sentimiento de soledad en el hogar. Conductas regresivas, conductas destructivas. Trabajo o asunción de roles del adulto. Consumo de sustancias tóxicas.

¿Cuáles son los hallazgos clínicos de SMI, en mayor frecuencia?

Los hallazgos clínicos que sugieren SMI:

- Hematomas:

En regiones protegidas o blandas: nalgas, espalda, tronco, brazos, genitales, cara interna de muslos, orejas, mejillas y cuello.

Con formas lineales.

Circunferenciales en muñecas

- Quemaduras:

Con tiempo de evolución mayor al referido por la historia.

Retraso de > 2 h en la búsqueda de atención

Distribución simétrica o múltiple.

Localización en perineo o nalgas.

Sugestivas de inmersión forzada: sin salpicaduras y límites netos entre piel afectada y sana, patrón en guante y calcetín, respeto de los pliegues de flexión.

Afectan el hemicuerpo posterior.

- Fracturas de Extremidades:

Múltiples en distintos estadios evolutivos.

Diafisarias en espiral u oblicuas.

Metafisarias en asa o en espículas secundarias a mecanismos de torsión y tracción simultánea.

Despegamiento subperióstico por hemorragia subperióstica.

Fractura de escápula.

- Formación de nuevo hueso subperióstico aparecido a los 7 a 10 días en forma de calcificación lineal.

Fractura, luxación y desplazamiento epifisario.

Cojera, acortamiento, deformación y desviación de extremidades como secuela.

Cráneo: son múltiples, bilaterales, cruzando las suturas, a veces conminutas, con hundimiento o diastasadas; asociadas o no a hematomas subdurales o hemorragias retinianas.

- **Costillas:** Múltiples, adyacentes, frecuentes en región lateral o posterior

- Lesiones oculares

Hematoma periorbitario en antifaz bilateral.

Catarata traumática y desprendimiento

- Lesiones abdominales y torácicas

Hematoma duodenal intramural.

Pseudoquistes traumáticos.

Ruptura, gástrica, duodenal, yeyunal, ileal o cólica. Desgarro hepático. Ruptura esplénica.

- Lesiones en el sistema nervioso central

Hematoma subdural sin fractura de cráneo asociada.

Hematoma epidural. Hemorragia intraventricular.

Atrofia cerebral.

Entre los traumatismos de cráneo cerrado se incluye el síndrome del bebé sacudido (shaken baby): lactantes sacudidos violentamente en sentido anteroposterior. Esto provoca desplazamiento de la masa encefálica y produce microhemorragias cerebrales y retinianas, hematomas por desaceleración brusca, que se expresa como somnolencia, sopor, irritabilidad y hasta el coma. Puede asociarse con fractura de costillas.

¿Qué estudios debemos solicitar frente a una sospecha de síndrome de maltrato infantil?

Ante la sospecha de Maltrato infantil, se solicita:

- ✓ Hemograma, hepatograma, función renal.
- Orina completa
- ✓ Radiografía de huesos largos
- ✓ Ecografía abdominal
- ✓ TAC de encéfalo
- ✓ Fondo de ojo

¿Cómo actuar frente a una sospecha de ASI?

- ✓ Ante la sospecha de un caso de Abuso sexual infantil, debemos recordar que existen diferentes tipos de abuso, en todos ellos el procedimiento se debe basar en los protocolos establecidos.
- ✓ Todos los datos deben quedar registrados en la historia clínica de forma detallada.
- ✓ Se debe realizar evaluación del riesgo para la salud y/o vida del paciente, en caso de que se sospeche de este corre riesgo, se decide internación del mismo.
- ✓ El examen físico debe realizarse en presencia de familiar de confianza, y siempre bajo el consentimiento del paciente, no forzarlo para evitar revictimización del mismo.
- ✓ Se realiza abordaje multidisciplinario: pediatría, Psicología, Asistente Social, Médico Legista, según corresponda.
- ✓ Se realiza Intervención, profilaxis y tratamiento.

En base a los hallazgos genital, se los clasifica:

Clasificación de los hallazgos anogenitales en niñas/os y/o adolescentes con sospecha de abuso sexual (Tomado de la clasificación realizada por Muram en 1988 con algunas mo-

dificaciones, de acuerdo con la clasificación de Adams de 1997)

- Categoría o Clase 1:

Sin datos de AS. Examen genital normal. (Recordar que la ausencia de signos físicos no invalida la posibilidad de ASI)

- Categoría o Clase 2:

Hallazgos inespecíficos de AS. Signos físicos que podrían estar causados por Abuso Sexual o por otra causa: vulvitis, lesiones por rascado, aumento de la vascularización del introito vaginal, fisuras en la piel o abrasiones en la horquilla vulvar, coalescencia de labios menores, presencia de secreción o flujo vaginal, presencia de condilomas en niña menor de dos años.

En la zona anal: presencia de hiperpigmentación o eritema perianal, apéndices cutáneos perianales, disminución de los pliegues perianales, congestión venosa, fisuras anales, dilatación anal con materia fecal en la ampolla rectal.

- Categoría o Clase 3:

Hallazgos específicos de AS. Presencia de uno o más signos sugestivos de AS: desgarros recientes o cicatrizales del himen, aumento del diámetro del orificio himeneal para la edad, desgarrado de la mucosa vaginal, marcas de dientes u otros signos traumáticos como laceraciones o equimosis en la vulva, presencia de gérmenes de transmisión sexual, condilomas en niñas/os mayores de dos años. En la zona anal: desgarros superficiales o profundos, cicatrices o tunelización, laxitud del esfínter anal, presencia de condilomas o de otros gérmenes de transmisión sexual, dilatación anal mayor a 20 mm sin materia fecal en la ampolla rectal.

- Categoría o Clase 4:

Hallazgos de certeza de AS:

Presencia de espermatozoides o líquido seminal en el cuerpo de la niña o adolescente. Embarazo. Evidencia del uso de la fuerza brusca o traumatismo penetrante, tal como la laceración del himen hasta la base o "hendidura completa".

Cultivos positivos para *Neisseria gonorrhoeae*, serología positiva para sífilis o para HIV (descartada la transmisión vertical).

Abuso con testigos o la existencia de fotografías o videos que prueben el AS. Confesión del supuesto agresor de los hechos

que describe.

Esta clasificación, nos orienta en el tratamiento médico posterior.

Se realizará únicamente en las situaciones que el caso lo justifique, es decir ante una violación o cuando haya sospecha o posibilidad de contacto de riesgo con las secreciones del agresor.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Tratamiento de lesiones corporales y/o genitales
2. Manejo infectológico de víctimas de violencia sexual

Profilaxis de infección por VIH, existen otros riesgos que también tenemos que prevenir: el del embarazo y el de otras infecciones de transmisión sexual: Hepatitis A y B, sífilis, gonorrea, Chlamydia trachomatis y tricomonas vaginalis, no debemos olvidar que existe una frecuente asociación entre estas infecciones y que existe sinergismo entre ellas. Se debe evaluar:

- ✓ La magnitud del riesgo de transmisión y si ha tenido agravantes (coito anal receptivo, sangrado, cantidad de violadores, etc.)
- ✓ El tiempo transcurrido desde que sufrió la agresión y la posibilidad que se pueda iniciar la profilaxis post exposición (PPE). Es importante saber que el tiempo ideal para iniciar el tratamiento es antes de las dos horas desde la exposición y que va disminuyendo su eficacia a medida que pasa el tiempo.

ACO emergencia: Levonorgestrel 150 mg dosis única

AZT

4-8kg: 12 mg/kg cada 12 hs.

9-29 kg: 9 mg/ kg cada 12 hs.

+ 30 kg: 300 mg cada 12 hs.

3TC

4 mg/kg cada 12 hs. (máximo 300 mg.)

Penicilina Benzatínica: 50.000 U kg (max 2.400.000 U)

Azitromicina 20 mg/Kg/dosis (máximo 1 gramo)

Metronidazol 30 mg/Kg/dosis (máximo 2 gramos)

Ceftriaxona 125 mg /dosis

Vacunación VHB

¿Que estudios debemos solicitar?

A todo niño/a o adolescente con sospecha de abuso o violación se le debe solicitar la siguiente rutina de laboratorio:

- Hemograma
- Hepatograma
- Sedimento de orina (para búsqueda de gérmenes o de espermatozoides),
- Urocultivo
- subunidad β HCG en las pacientes
- Test de HIV por ELISA, con su consentimiento
- Debe solicitarse estudios serológicos para hepatitis A, B y C:
- Hepatitis A: Ig M e IgG anti HVA
- Hepatitis B: se solicita Ig M, IgG anticore (antiHBc) y HBsAg.
- Hepatitis C: se solicita anti HCV (ELISA)

¿Qué hacer en caso de una niña embarazada?

Independientemente de la edad de la niña, o adolescente y de su capacidad mental, en caso de violación debe ser informada sobre su *Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales*, derecho a la realización de una interrupción legal del embarazo –también conocida como aborto no punible– y de acceder a la práctica si así lo decide.

En todos los casos, debe garantizarse el aborto legal sin demoras. No es función de los equipos de salud verificar si ocurrió o no la violación, ni indagar sobre las circunstancias en que se produjo. El único requisito para realizar la ILE es que la mujer firme una declaración jurada y un consentimiento informado. En ningún caso corresponde requerir la denuncia policial o judicial o la presentación de pruebas de la violación para la realización de una ILE.

Cuando la mujer o su representante hicieron una denuncia por violación, es necesario realizar el procedimiento de tal forma de poder recolectar material genético como evidencia forense.

Comentario Jurídico

Dra. María del Rosario Mesiano

En nuestro sistema penal argentino el abuso sexual está tipificado y es reprimido con prisión o reclusión cuando la víctima fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia,

amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

Este delito, se encuentra ubicado en el Código Penal, en el articulado correspondiente a “Delitos contra la Integridad Sexual”, cuyas acciones dependen de instancia privada, siempre y cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o las lesiones sufridas no sean graves, es decir que, si no se cumplen estos presupuestos, no se formula causa penal por el delito sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales.

Afortunadamente, con la modificación que introdujo la Ley 27.455 al Código Penal en el año 2018 el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de instancia pública. Con lo cual, los profesionales de la salud o cualquier persona que tome conocimiento del delito, podrá denunciarlo y el Estado tiene la obligación de investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Previo a la modificación, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratificara la denuncia terminaba siendo un obstáculo para que haya justicia, toda vez que la misma ley muchas veces terminaba apañando la conducta delictiva del perpetrador del abuso, que resultaba siendo el progenitor o representante legal.

Se entiende por abuso sexual a una forma de violencia que atenta contra la integridad y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, que se configura cuando un adulto/agresor hace intervenir a un niño/a o lo usa para actos sexuales, con o sin contacto físico, para estimularse él mismo, estimular al propio niño/a o a otra persona. Incluyen los tocamientos indebidos, manoseos, violaciones, explotación o pornografía, obligar a un niña o niño a observar actos sexuales de otros (sean adultos o NNyA), entre otros. Pueden existir abusos sexuales realizados por un niño menor de 18 años cuando entre el agresor y la víctima existe fuerza o asimetría de poder o diferencias etarias significativas entre el agresor y víctima. Asimismo, es necesario aclarar que puede haber abuso sexual infantil

aunque no haya acceso carnal.

El abuso sexual puede ocurrir en el hogar, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, dentro de las comunidades, entre otros. Los agresores pueden ser del ámbito familiar, conocidos, vecinos, o desconocidos y pueden ser de cualquier nivel socioeconómico y educativo. Este constituye un flagelo creciente a nivel mundial. Pese a ello, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. De acuerdo con datos mundiales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sido abusados sexualmente durante su niñez. En este sentido, es necesario sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la frecuencia y gravedad de esta problemática y lograr que se desnaturalice el abuso sexual como un tema privado y comience a ser tratado como una cuestión pública y un delito grave. Es fundamental trabajar en la prevención y en la protección de manera interinstitucional, asimismo, los organismos deben contar con lineamientos especializados de actuación con perspectiva de género y de derechos humanos. Quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias y además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial.

Bibliografía

- Bestalia Sanchez de La Cruz. *Ginecología Infantojuveni*. Editorial Panamericana 2013.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. *Protocolo para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual*.
- Indart MJ. *Manejo de la urgencia. Capítulo 2. ¿Qué hacer cuando se sospecha que un niño ha sido abusado sexualmente?*
- Lewitan G. *Ginecología de niñas y adolescentes* Ediciones Journal 2013.
- Pronap 2009. *Abuso sexual infantil*.
- Reichenbach J et al. *Pediatría en Red 2*. Ministerio de Salud, 2017.

***Dra. María Del Rosario Mesiano** *Revisora*
Abogada Especialista en Derecho y Salud

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA

Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra de La Plata.

Unidad de Residencia de Pediatría



Dra. Rosario Barrales

Jefa de Residentes

Dr. Sebastián Irastorza

Residente

Dra. Cecilia Inés Luna

Instructora de Residentes

Dra. Marisa Fernández Cordero

Jefa de Unidad de Cuidados Prolongados

Dra. Viviana Balbi

Revisora

Dra. Verónica González

Revisora

Servicio de Endocrinología

Sumario

La deficiencia suprarrenal constituye una emergencia grave que pone en riesgo la vida del paciente. Es un cuadro originado por deficiencia glucocorticoidea y / o mineralocorticoidea no siempre presente, que de no ser adecuadamente diagnosticado y tratado origina gran morbilidad y mortalidad. El pediatra y el médico de guardia deben estar alertas y saber que se encuentran ante un paciente de alto riesgo

Situación clínica/caso problema

Motivo de consulta: Niño de 6 meses de vida que ingresa a la guardia de hospital Interzonal por presentar fiebre, letargia, vómitos e hipotonía.

Historia clínica y examen físico

Lactante en regular estado general, palidez cutáneo mucosa generalizada, xerodermia, disminución del tejido celular subcutáneo, pelo fino e

hipopigmentado, hipertelorismo ocular. Cicatriz de BCG presente.

Aspecto desnutrido, hiporreactivo, fontanela deprimida, enoftalmos, mucosas secas y signo del pliegue positivo. Pulsos periféricos presentes y relleno capilar 3". Diuresis y catarsis negativa en las últimas 8 hs.

Genitales según fenotipo masculinos normales, testículos en bolsas. Marcada hipotonía generalizada con hiperreflexia, sin sostén cefálico.

SV: FC 150 lpm, FR 44 rpm, SatO₂ 98% A/A, T° 38.3 axilar, TA: 80/50 mmHg TAM: 60

Antropometría: Peso 5.300 g (-3,73 DE), Talla 64 cm (-2,99 DE), PC 42 cm (-3 DE). Desnutrición crónica descompensada (adecuación P/T: 75.7%)

Antecedentes perinatólogicos: RNT/ AEG. PN 3.300 g. Apgar 9/10. Padres no cosanguíneos.

Antecedentes de enfermedad actual: Según relato materno el niño comienza con vómitos, no precedidos de náuseas, rechazo alimentario e irritabilidad de aproximadamente seis a ocho

horas de evolución.

Antecedentes personales: Se encuentra en seguimiento por desnutrición crónica, habiendo presentado intercorrientes respiratorias, digestivas y del tracto urinario en los últimos 3 meses.

Antecedentes familiares: Medio socio económico desfavorable.

Exámenes de laboratorio: Leucocitos 13.800/mm³ (N 60/L 40) Hb 9,1 gr%, Hto 28% Plaquetas 309.000/mm³ Glucemia 0.71 g/L. Urea: 0.50, creatinina: 6.9. PCR 110.

Nomoionograma: Acidosis metabólica. Sodio 111 mEq/l, potasio 6,9 mEq/l, cloremia 87 mEq/l.

Hepatograma: TGO: 396 UI/litro, TGP 250 UI/litro. GammaGT normal. Coagulograma: normal. CPK: 14.625 UI/litro CPK MB: 263 UI/litro. Triglicéridos: 611 mg/dL.

Preguntas

¿Cuál es su interpretación diagnóstica y los posibles diagnósticos diferenciales?

Interpretación diagnóstica: Niño de 6 meses de vida con desnutrición crónica descompensada, cursando cuadro compatible con deshidratación grave acompañada de acidosis metabólica, hiponatremia e hipercalemia, a descartar etiología:

- ✓ Infecciosa
- ✓ Metabólica
- ✓ Endocrinológica
- ✓ Toxicológica

Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos citar:

- ✓ Sepsis a descartar etiología
- ✓ Gastroenteritis aguda con deshidratación moderada
- ✓ Insuficiencia suprarrenal aguda, a descartar primaria o secundaria
- ✓ Intoxicación folclórica
- ✓ Enfermedades congénitas del metabolismo

¿Qué preguntas adicionales incluirían para profundizar la anamnesis?

- ✓ Grado duración y forma de medición de la temperatura
- ✓ Epidemiología familiar
- ✓ Inmunización y aplicación reciente de vacunas

- ✓ Alteraciones del patrón de sueño y comportamiento
- ✓ Indagar sobre síntomas acompañantes
- ✓ Consultar sobre internaciones previas
- ✓ Profundizar en antecedentes perinatólogicos y antecedentes familiares
- ✓ Revisar resultado de errores congénitos del metabolismo.
- ✓ Prestar especial atención en examen genitourinario
- ✓ Interrogar acerca de alimentación e inicio de alimentación complementaria
- ✓ Indagar sobre posibles pérdidas concurrentes, como aumento del número de deposiciones o sudoración profusa
- ✓ Preguntar acerca de tratamiento médico de base, y posibilidad de consumo de sustancias tóxicas (fármacos, infusiones caseras como paico, anís estrellado, manzanilla)

¿Qué datos relevantes tomaría en cuenta para decidir la internación de Thiago?

- ✓ Estado de hidratación
- ✓ Intolerancia oral y rechazo alimentario
- ✓ Sensorio

¿Realizaría algún otro estudio complementario, además de los ya realizados?

- ✓ Hemocultivos x 2/ Sedimento urinario y Urocultivo/Cultivo y citofisicoquímico de LCR
- ✓ Rx de tórax
- ✓ Ecografía cerebral y abdominal
- ✓ Perfil lipídico completo.
- ✓ Dosaje de Cortisol plasmático, ACTH y 17 OH progesterona

¿Cuál es el tratamiento inicial que realizaría en este paciente?

Realizar el ABC en el paciente, actuar con premura, colocar vía periférica para rehidratación endovenosa. Corregir la hipovolemia y de ser necesario el desequilibrio electrolítico. Evaluar dinámicamente la necesidad de expansión con solución fisiológica a 20 mg/kg

Una vez estabilizado tomar muestras para cultivos (Hemocultivos x 2/ Urocultivo/ Cultivo de LCR)

Colocar tratamiento antibiótico empírico: Ceftriaxona 100 mg/kg/día

En caso de inestabilidad hemodinámica y regular respuesta al tratamiento instaurado y ante la sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda se inicia tratamiento de la crisis con hidrocortisona IV en dosis de estrés: 20 mg en push (48 mg/m²/dosis), seguida por 5 mg (48 mg/m²/día), cada 6 hs.

Evolución

Luego del tratamiento inicial el niño permanece estable hemodinámicamente, cultivos negativos que descartan la etiología infecciosa. Por persistencia de hiponatremia e hiperkalemia con la terapia hídrica y, bajo la sospecha diagnóstica de insuficiencia suprarrenal aguda, se realiza interconsulta con los servicios de Endocrinología y Genética. Los niveles hormonales demostraron déficit corticosuprarrenal. Esto sumado a la elevación de creatinquinasa (CK) e hipertrigliceridemia (TG) hizo pensar en una forma compleja de déficit de Glicerol quinasa que engloba hiperglicerolemia, hipoplasia suprarrenal congénita y distrofia muscular. El estudio citogenético arribó al diagnóstico de Deleción de genes contiguos.

El paciente presentó buena evolución clínica con terapia con hidrocortisona y fludrocortisona y suplementos de ClNa, logrando mejorar el progreso pondoestaural pero presentando retraso global de pautas del desarrollo. Se encuentra en seguimiento interdisciplinario.

Actualización

La insuficiencia suprarrenal (IS) es la incapacidad de las adrenales para mantener una secreción hormonal adecuada, no sólo en situación basal, sino también durante el estrés, lo cual conlleva a una emergencia grave para la vida del paciente.

Se clasifica en insuficiencia suprarrenal primaria por alteraciones en la glándula suprarrenal,

la cual presenta en general compromiso glucocorticoideo y mineralocorticoideo, y secundaria debida a una falla en la región hipofisaria, sin deficiencia mineralocorticoidea.

Los pacientes pueden no presentar síntomas que alerten precozmente, como anorexia, náuseas, astenia, vómitos y dolor abdominal. De no corregirse el cuadro, aparecen hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia con hiperpotasemia, deshidratación y shock.

Es indispensable, aun en caso de duda, corregir la hipovolemia, el desequilibrio electrolítico y la hipoglucemia, y administrar glucocorticoides a dosis de estrés. Superada la fase aguda, administrar la dosis de corticoides de mantenimiento y, en caso necesario, añadir mineralocorticoides.

¿Cuándo aparece?

- En condiciones de estrés, es decir ante una infección viral o bacteriana, fiebre, diarrea, o interurrencias, ya sean leves o graves.
- Ayuno prolongado.
- Al suspender en forma brusca el tratamiento establecido para el reemplazo corticoideo.
- ¿Cómo se manifiesta?
- A veces, no existen síntomas que alerten precozmente.
- En primera instancia, aparece anorexia, náuseas y astenia, seguidos de vómitos y dolor abdominal.
- Hipotensión, hipoglucemia, deshidratación, shock.
- Convulsiones, estado confusional.
- En los casos de insuficiencia adrenal primaria se puede observar hiperpigmentación de piel y mucosas, y pérdida de peso, acompañada a veces por pérdida salina.
- Hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, urea alta prerrenal, anemia, eosinofilia. Corresponde pensar en esta posibilidad en los pacientes en riesgo, aun sin síntomas específicos, en el caso de infecciones, diarrea, inter-

	ACTH (pg/ml)	Cortisol (ug/dl)	Sodio (mEq/l)	Potasio (mEq/l)	CK (U/l)	TG (mg/dl)
Al ingreso	150	5	111	6.9	14.625	611
Pos tratamiento	< 10.3	Suplementado	145	4.9	11000	550n

CAUSAS DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL			
1.INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA	1 A. CAUSAS GENÉTICAS O HEREDITARIAS	Alteraciones de esteroidogénesis	Hiperplasia Suprarrenal congénita
		Disgenesia adrenal	Hipoplasia suprarrenal congénita
			Síndrome de resistencia aislada a ACTH
		Destrucción adrenal	Adrenalitis Autoinmune
			Adrenoleucodistrofia
			Enf. Depósito
	1 B. CAUSAS ADQUIRIDAS	Hemorragia Adrenal	
		Enfermedades Infecciosas (TBC-SIDA, micosis, parasitosis)	
		No Infecciosas: Tóxicos-Traumatismos, Metástasis, Inflamatorias (Enfermedad de Addison)	
2.INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA	2. A CAUSAS GENÉTICAS O HEREDITARIAS	Post-quirúrgicas	
		Deficiencia de ACTH	
	2 B. CAUSAS ADQUIRIDAS	Corticoterapia Crónica (S. Cushing)	
		Lesiones Hipotálamohipofisarias (Tumores, Infecciones, Radioterapia)	

Tabla 1. Causas de Insuficiencia suprarrenal en Pediatría. Propia creación

currencias, ayuno prolongado.

Diagnóstico

El diagnóstico de Insuficiencia Suprarrenal se basa en la demostración de niveles disminuidos o indetectables de cortisol plasmático con hiporrespuesta al estímulo con ACTH en el caso de Insuficiencia Suprarrenal Primaria.

Primer paso: Dosaje de Cortisol (si hay sospecha clínica hay que extraer la muestra antes del tratamiento sustitutivo con corticoides) 17 OH progesterona y ACTH.

Si el cortisol basal es $>8-10 \mu\text{g/dl}$ o $>18-20 \mu\text{g/dl}$ en estrés: es normal.

Si el cortisol basal es $< 3 \mu\text{g/dl}$ o $< 5 \mu\text{g/dl}$ en situación de estrés: Solicito ACTH.

Si ACTH es $> 100 \text{ pg/ml}$: insuficiencia primaria

Si ACTH es $< 16 \text{ pg/ml}$: insuficiencia secundaria o terciaria

SI ACTH normal: hacer test de estimulación:

Test con dosis estándar de ACTH ($250 \mu\text{g}$): si el cortisol es $>18-20 \mu\text{g/dl}$: eje normal, descarta insuficiencia adrenal. Cortisol $< 18 \mu\text{g/dl}$: posible

insuficiencia 2ria o 3ria.

Nivel sérico de cortisol en hipoglucemia: Estudio que se realiza en ayunas bajo internación. Se toma una muestra de cortisol en distintos tiempos post administración de insulina ultrarápida IV en el tiempo 0. Insulina $0,1 - 0,25 \text{ UI/kg}$ por vía EV. La hipoglucemia es un factor de estrés que hace que el hipotálamo libere CRH. Si el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal está intacto induce aumento de ACTH y cortisol.

Es patológico un valor de cortisol $< 18 \mu\text{g/dl}$ con una glucemia $< 40 \text{ mg/dl}$.

Pruebas de determinación de AC antisupearrenales o anti 21- hidroxilasa, así como estudios genéticos se realizan en una segunda fase.

Tratamiento de la Insuficiencia suprarrenal Aguda

Es una emergencia pediátrica. Ante la sospecha clínica se debe hospitalizar al paciente e iniciar tratamiento sustitutivo sin esperar los resultados hormonales.

El tratamiento es independiente de la causa

de insuficiencia adrenal.

La prioridad es reponer la volemia, corregir los disturbios hidroelectrolíticos e iniciar tratamiento sustitutivo con corticoides parenterales.

¿Cómo se trata?

Es indispensable, aun en caso de duda, actuar con premura, colocar inmediatamente un suero para aportar glucosa y cloruro de sodio de acuerdo al estado de hidratación.

Corregir la hipovolemia, el desequilibrio electrolítico y la hipoglucemia.

Administrar hidrocortisona IV en dosis de estrés: 25 mg en bolo, seguida por 25 mg/d dividida en 4 dosis (c/6 h) para niños menores de 3 años; 50 mg seguidos de 50 mg/d para niños 3-12 años; 100 mg seguidos de 100 mg/d en adolescentes y adultos. Estas dosis tienen, per se, actividad mineralocorticoide; por lo tanto, no se requiere añadir 9- α -fluorhidrocortisona en la fase aguda.

En caso de no poder acceder a la vía IV inyectar por vía IM 50-100 mg de hidrocortisona. Esta última vía tiene un tiempo de demora en la absorción que puede estar agravada por la vasoconstricción, que disminuye el flujo de la inyección IM.

Habiendo estabilizado al paciente seguir con aporte IV de hidrocortisona 10-20 mg (o 30 mg/m² /día) cada 6 hs.

Superada la fase aguda, si el paciente se siente bien y come normalmente, la dosis de glucocorticoides puede ser descendida a la fisiológica de reemplazo (15 mg/m² /día) con el suplemento del mineralocorticoide (9- α -fluorhidrocortisona 0,05-0,1 mg/día) si lo requiere y evaluar requerimiento de sal extra.

Prevención de la crisis adrenal

La secreción de cortisol aumenta sustancialmente durante las situaciones de estrés, por lo cual, todo paciente con insuficiencia adrenal primaria o secundaria, incluidos los que hasta hace un año hayan estado con dosis farmacológicas prolongadas de corticoides (aún en el caso de tener concentraciones actuales de cortisol basal normales), debe incrementar la dosis de gluco-

corticoides en esas circunstancias para prevenir la crisis adrenal.

1. En caso de estrés leve (fiebre, enfermedades sin compromiso del estado general, etc.) se deberá duplicar la dosis de hidrocortisona que el paciente recibe diariamente, dividida cada ocho horas, por vía oral, por el término de 24-48 hs o hasta que remita el cuadro de base.

2. Cuando exista intolerancia oral o no pueda asegurarse una correcta absorción (diarreas, vómitos) se deberá utilizar la vía IM. Administrar hidrocortisona a la dosis de 30 mg/m² /día, repartidos en cuatro dosis, hasta la tolerancia oral.

3. Para estrés graves, como sepsis, grandes quemados, cirugía mayor, etc., utilizar el esquema de crisis, de preferencia siempre con hidrocortisona, aun en pacientes en tratamiento con otros compuestos corticoideos.

4. En caso de preoperatorio se aconseja administrar una hora antes de la anestesia, hidrocortisona IM 50 mg en los niños menores (hasta 12 años) o 100 mg en los mayores (adolescentes y adultos). Durante la cirugía, indicar la misma dosis en goteo continuo IV. Superado el acto quirúrgico, seguir con aporte IV de hidrocortisona 25 mg/día dividida en 4 dosis (c/6 h) para niños menores de 3 años; 50 mg seguidos de 50 mg/día para niños 3-12 años; 100 mg seguidos de 100 mg/día para adolescentes y adultos. Con estas dosis no se requiere la administración adicional de 9 α -fluorhidrocortisona.

Bibliografía

- Grau G, Vela A, Rodríguez Estévez A, Rica I. Insuficiencia suprarrenal. *Protoc diagn ter pediatr*. 2019;1:205-15
Güran T. Latest insights on the etiology and management of primary adrenal insufficiency in children. *J Clin Res Pediatr Endocrinol*. 2017;9(Suppl 2):9-22.
Kozak A. Diagnostico Insuficiencia suprarrenal. Hospital Italiano - Laboratorio de Endocrinología y Med. Nuclear "in Vitro". HIBA 2013
Maguelone G, Forest Laura, Audi Parera M, Fernández Canci. *Hipofunción Suprarrenal Capítulo55 tratado de Endocrinología Pediátrica Pombo 4ta Edición*
Martínez A, Pasqualini T, Stivel M y col. Emergencia pediátrica: insuficiencia suprarrenal aguda. *Arch Argent Pediatr* 2010; 108 (2): 161-170.
Ricci J, Morín A, González V, Balbi V. Guía de manejo de la insuficiencia suprarrenal aguda. *Ludovica Pediátrica - VOL 20 #01 - Septiembre 2017*

HIRSUTISMO E HIPERTRICOSIS

Hospital Municipal Materno Infantil de Tigre Dr. Florencio Escardo.
Residencia de Clínica Pediátrica



Dra. Emilia Breppe

Endocrinóloga Servicio de Pediatría

Dra. Liliana Alfano

Jefa de Servicio

Dra. Eliana Maddaleno

Instructora de Residentes

Dr. Lionel Proietti

Jefe de Residentes

Dra. Julia Tamburini

Dra. Mercedes Villamil

Dra. Victoria Bordo

Residentes 2º año

Sumario

El hirsutismo y el acné que se presentan como parte del desarrollo en el adolescente también son parte de una enfermedad de característica crónica, por lo que se debe tener en claro la definición del mismo para poder distinguir de lo fisiológico de lo patológico.

El diagnóstico de Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) en la adolescencia conduce a la toma de conciencia de esta condición asociada a complicaciones hormonales y metabólicas, que podrían ser de por vida.

Caso clínico

Es traída a la consulta una niña de 7 años por

presencia de vello púbico y olor apócrino.

Antecedentes personales: nacida a término con peso adecuado para la edad gestacional, embarazo controlado, apgar 9/10, serologías maternas negativas. FEI normal. Sin antecedentes personales a destacar.

Alimentada a pecho exclusivo hasta los 6 meses y desarrollo neuromadurativo acorde a edad.

Antecedente familiares: padres obesos, menarca materna a los 10 años.

Al examen físico: sobrepeso, sedentaria, escolarizada y con buen rendimiento escolar. Mamas sin desarrollo (grado I), Vello pubiano escaso largo grueso y enrulado (grado II). Genitales sin estrogenizar (grado I). Sin vello axilar pero refiere con olor apocrino. Abdomen globuloso, no se

palpa bocio, sin otras alteraciones.

Se realiza ecografía abdominal y suprarrenal que son informada sin alteraciones, se agregaron ecografía ginecológica normal para la edad (útero 26mm x7mmx12mm Ovario Derecho 0.87cm³ Ovario Izquierdo 0.94ml), y edad ósea 9 años para 7 años de edad cronológica (normal dentro de límite superior) se deriva al especialista pero discontinúa controles.

Vuelve a la consulta a los 14 años por exceso de vello en cara, tórax y espalda, irregularidades menstruales y obesidad.

Como antecedentes, menarca a los 10 y 6 meses de edad, refiere ciclos de mayores a 45 días de duración alternados periodos de amenorreas secundarias. Peso 82 Kg, talla 1.59cm, IMC32. Abdomen globuloso, con obesidad central, sin visceromegalia, acantosis en cuello axilas e ingle. Hirsutismo en áreas de mentón, areolas mamarias, espalda, piernas y brazos.

Se solicitó ecografía ginecológica útero 60mmx20mmx11mm, Ovario Derecho 8cm³, Ovario Izquierdo 7 cm³, se describen ambos polifoliculares, edad ósea de 16 años acorde para la edad, y laboratorio hormonal: FSH 4ml/UI, LH 10ml/UI estradiol 40pg/ml, 17Oh progesterona 1.7ng/ml, Testosterona Total 51ng/dl, SDHEA 300 ng/ml, GLae 20 nmol/L, Androstenediona 1ng/ml. (presenta un hiperandrogenismo con una relación FSH, Lh alterada). Además Colesterol total de 250, triglicerido 180, glucemia 90 e insulina 35, (hiperlipemia e hiperinsulinismo)

Diagnóstico: Síndrome de ovario poliquístico en adolescente

REFLEXIÓN CLÍNICA

Es importante realizar el examen físico completo del paciente desde la primera consulta incluyendo los genitales, conocer la normalidad de las estructuras para detectar las variaciones y evitar diagnósticos tardíos.

El hirsutismo y el acné que se presentan como parte del desarrollo en el adolescente también son parte de una enfermedad de característica crónica, por lo que se debe tener en claro la definición del mismo para poder distinguir de lo fisiológico de lo patológico.

El diagnostico de SOP en la adolescencia conduce a la toma de conciencia de esta condición asociada a complicaciones hormonales y metabólicas, que podrían ser de por vida. Permite una oportunidad para efectuar intervenciones significativas y mejorar la hiperandrogenemia, siendo fundamental proporcionar recomendaciones para un estilo de vida saludable y atender las posibles comorbilidades.

DEFINICIONES

Hirsutismo: Es el exceso de crecimiento de vello corporal en la mujer en zonas androgénicas. En general, se debe a un aumento de la producción de andrógenos o a una mayor sensibilidad cutánea a los andrógenos. Se utiliza para su evaluación score Ferriman-Gallwey Modificado (imagen 1), en el que se evalúan 9 regiones

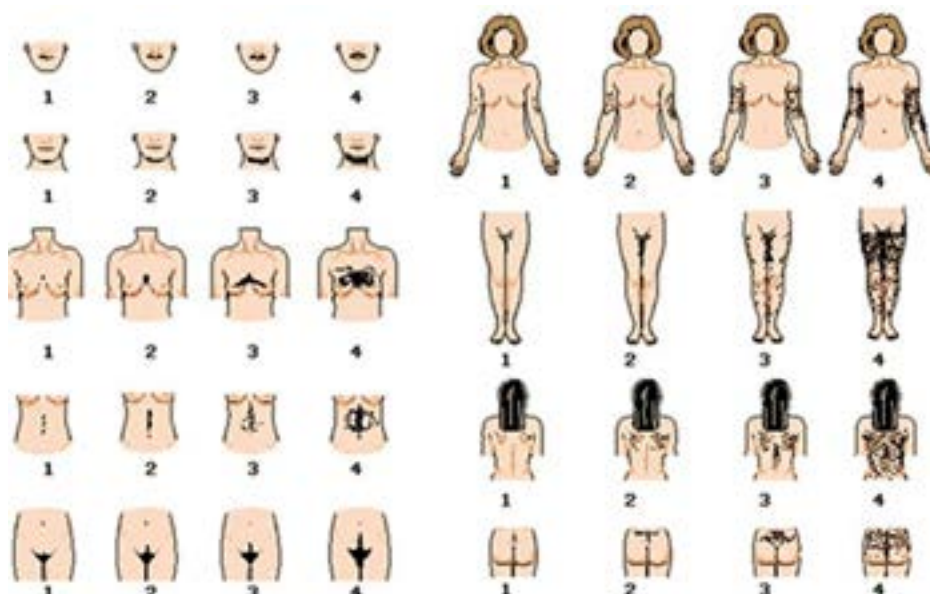


Imagen 1

(labio superior, barbilla, pecho, espalda superior y baja, abdomen superior e inferior, brazo, antebrazo, muslo y parte inferior de la pierna); se otorga un puntaje del 1 al 4 en cada región, según la cantidad de vello. Se define como hirsutismo leve, moderado o severo con un puntaje de 8 a 15, de 16 a 25 y mayor de 25.

Hipertricosis: Es el aumento de pelo corporal en zonas donde ya existe normalmente en la mujer; habitualmente no se debe a un exceso de andrógenos, sino que depende de factores raciales, farmacológicos y familiares.

Ciclo menstrual: es el período comprendido entre el comienzo de una menstruación y el inicio de la siguiente. Su duración promedio es de 28 días y se divide en dos períodos, la fase folicular, del día 1 al 14 y la fase lútea, del 15 al 28. Entre las dos fases se produce la ovulación.

Las alteraciones del ciclo menstrual se pueden dividir en (Tabla 1):

- ✓ Alteraciones del ritmo.
- ✓ Alteraciones de la cantidad.

Si bien la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovárico es una de las causas más frecuentes, es importante destacar que su diagnóstico es de exclusión, debiendo descartarse toda causa de origen orgánico o funcional.

Obesidad: es una enfermedad crónica, multifactorial (OMS, 1997) caracterizada por el aumento de la grasa corporal, para su evaluación se utilizan mediciones antropométricas para estimar indirectamente la magnitud y la distribución del tejido adiposo: peso, talla y circunferencia de cintura, sin embargo el Índice de Masa Corporal (IMC) es el indicador más aceptado para evaluarla en ámbitos clínicos y epidemiológicos. Debe incluirse en el control pediátrico a partir de los 2 años. Se calcula a partir del peso y la talla. $IMC = P/T^2$ ó $P/T \cdot T$.

Síndrome Metabólico (SM)

Se caracteriza por la presencia de insulinorresistencia e hiperinsulinismo compensador asociados a trastornos del metabolismo hidrocarbonado, HTA, alteraciones lipídicas y obesidad,

TABLA 1. Alteraciones del ciclo menstrual

		Intervalo	Duración	Cantidad
Alteraciones del ritmo	Polimenorrea	< 21 días	2-7 días	50-120 ml
	Oligomenorrea	35-90 días	2-7 días	50-120 ml
	Amenorrea secundaria	> 90 días	-	-
Alteraciones de la cantidad	Hipermenorrea	25-35 días	≥ 7 días	> 120 ml
	Hipomenorrea	25-35 días	< 2 días	< 50 ml

Tabla I. Clasificaciones SM			
Clasificación	NCEP ATP III (1)	OMS (2)	IDF (3)
Criterios presentes	3 o más	IR/ITOG/DBT * + 2 o más	Obesidad central* + 2 o más
Obesidad	Cintura >88 cm	IMC >30 o Índice cintura cadera >0,85	Cintura >80 cm*
Triglicéridos (mg/dl)	≥150	≥150	≥150
HDL col	<50	<39	<40
TA	≥130/85	≥160/90	≥130/85
Glucemia en ayunas	≥100	IR/ITOG/DBT	≥100 o DBT previa
Otros		Microalbuminuria	

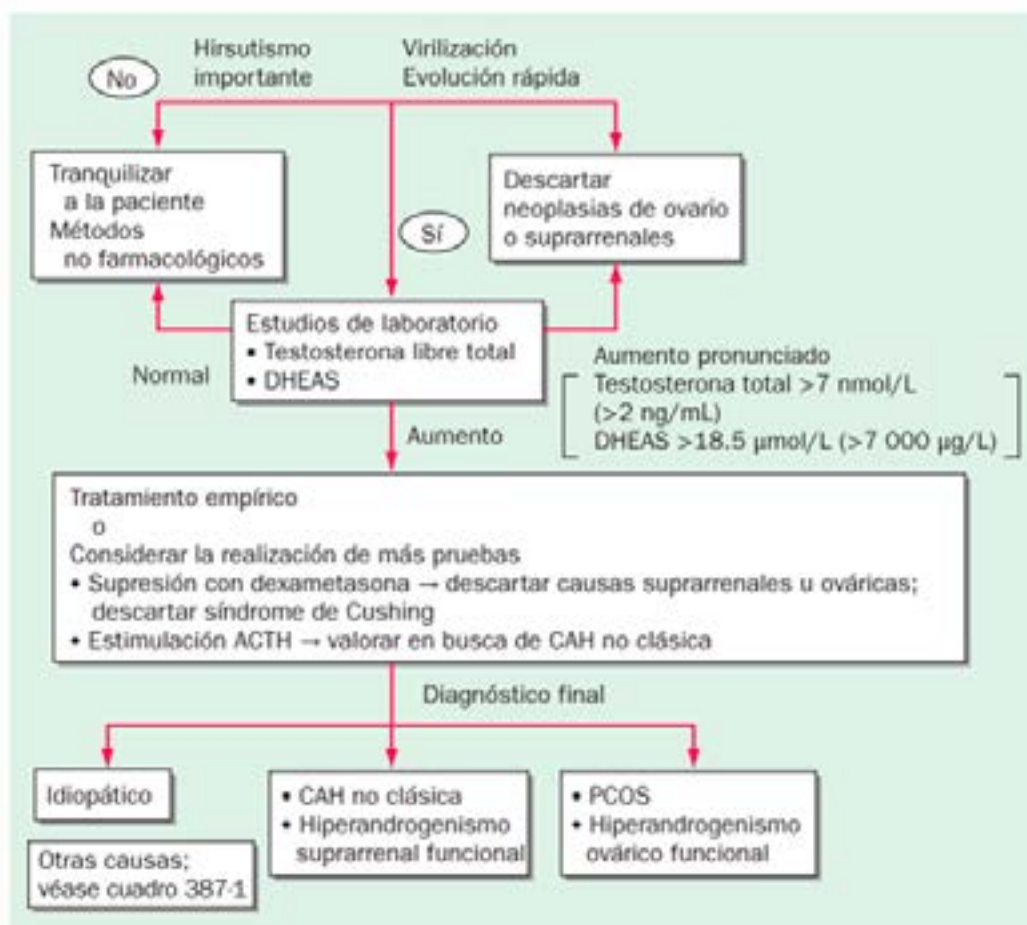
TA: tensión arterial; ITOG: índice de tolerancia oral a la glucosa; DBT: diabetes

*Siempre deben estar presentes

(1) National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III

(2) Organización Mundial de la Salud

(3) Federación Internacional de Diabetes



Fuente: J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo: Harrison. Principios de Medicina Interna, 20e Copyright © McGraw-Hill Education. Todos los derechos reservados.

Tabla II. Criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico⁽¹⁴⁻¹⁶⁾

<i>Criterios NIH</i>	<i>Criterios de Rotterdam</i>	<i>Criterios AE-PCOS</i>
1. Oligoovulación	1. Oligo y/o anovulación	1. Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico
2. Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico	2. Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico	2. Disfunción ovárica (oligo-anovulación y/o ovarios poliquísticos)
3. Ovarios poliquísticos		

Los criterios 1 y 2 son necesarios para el diagnóstico del SOP según criterios NIH. Los criterios de Rotterdam requieren la presencia de dos de los tres criterios. Para definir el SOP según criterios AE-PCOS, es siempre necesaria la presencia de hiperandrogenismo, además de la disfunción ovárica. En cualquier caso, es necesario excluir otras etiologías tales como: hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos e hiperprolactinemia.

con un incremento de la morbilidad y mortalidad de origen aterosclerótico (tabla 1).

Síndrome ovárico poliquístico (SOP) es el desorden endócrino más común en mujeres en edad reproductiva en el mundo. El SOP se manifiesta con hiperandrogenismo y anovulación crónica en la adolescencia. Su etiología se cree que es multifactorial, donde los factores genéticos y la epigenética son los responsables en la aparición posmenarca del SOP.

Para su diagnóstico, luego del Consenso de Rotterdam, en el 2003, la Sociedad de Exceso de Andrógenos en conjunto con la Sociedad de SOP recomendó considerarlo a todo paciente con hiperandrogenismo clínico (hirsutismo y/o acné) o bioquímico (testosterona total >50 ng/dL o de testosterona libre > 24 pmol/L) como condición suficiente y necesaria además de la presencia de irregularidades menstruales (intervalos menstruales consecutivos > 90 días aún en el primer año postmenarca, intervalos persistentes > 45 días a los 2 o más años después de la menarca o la falta de ciclos a los 15 años habiendo transcurrido 2-3 años del desarrollo mamario) o morfología ovárica poliquística (MOP), aunque esta última no se considera como criterio en adolescentes, aun así en niños.

Bibliografía

- Escobar ME. Trastornos del ciclo menstrual en la adolescencia. *Mensual. Comité Nacional de Endocrinología*, 2010.
- Hassan A et al. Síndrome ovárico poliquístico. *Revista de pediatría Hospital de Niños R. Gutierrez* 2018; 60(270):258-263
- Setton y Patricia Sosa. *Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad*.

TECNOLOGÍA 10 – HUMANIDAD 0



Dr. Juan Miguel Cotrofe*

Había una vez un viejo hospital, muy viejo. Como era de esperar un día decidieron tirarlo abajo y hacer uno nuevo. Pero también decidieron hacerlo especializado Materno Infantil. Y así nació el HIEMI en Mar del Plata. No voy a contar la historia del hospital, sólo relataré algunos aspectos de la UCIP donde trabajé por treinta años.

La Unidad nació de cero. No había infraestructura ni personal, sólo buena voluntad y desde ese lugar llegó a ser con el tiempo un centro de referencia.

Todo comenzó en la parte vieja, en lo que era la Sala 1. Cinco camas, un lavabo y un pequeño office. Los techos eran muy altos, los pisos tan gastados que no se distinguían sus antiguas figuras. Corría el año 1981 y la obra nueva planeaba inaugurarse en 1983.

Dos médicos comenzamos a hacerla funcionar y así fue hasta que se incorporaron algunos más para poder hacer una guardia cada uno.

Contábamos con un respirador Neumovent hasta que llegaron los Bennet MA1 y MA2, veteranos de Vietnam y totalmente reciclados. Las soluciones de diálisis se preparaban en un rincón, midiendo ml a ml el contenido que calculábamos haciendo innumerables cuentas.

Tuvimos una racha de quemados, a los primeros los derivábamos al Ludovica de La Plata hasta que comenzamos a animarnos y sin quererlo junto a los cirujanos plásticos se formó un equipo muy importante para tratar grandes quemados.

En 1982 llegó Malvinas y decidieron adelantar las obras y convertirlo en hospital para recibir heridos de guerra, lo que nunca sucedió.

En el nuevo hospital había un espacio para la Unidad, construido especialmente con ese fin,

para nosotros un lujo. Cerca de los quirófanos, con personal completo y fijo, con una provisión envidiable de material y equipamiento.

Y casi como en un cuento nos encontramos cada día mejor ambientados y en condiciones de hacer un trabajo de calidad. Había más especialistas lo que permitía tratamientos adecuados; la complejidad iba en aumento.

Con el paso de los años, no recuerdo cuántos, se hicieron reformas en el edificio y nos asignaron un nuevo espacio, mucho más amplio, con ocho camas bien separadas, tres de aislamiento, depósitos y más personal. Hasta un pequeño departamento dentro de la Unidad para los médicos de guardia que a esa altura éramos dos cada día. Allí había central de gases y vacío. Equipamiento nuevo, lujo asiático para lo que eran los hospitales provinciales de esa época. Pedíamos y nos proveían. Eran tiempos de vacas gordas y los resultados de nuestro trabajo superaba las expectativas de las autoridades.

Todo muy lindo, hubo rotación de residentes, guardias de todas las especialidades, gran respaldo técnico y muchas ganas de aprender.

Pero – siempre hay uno – a mí en lo personal me faltaba algo. Habíamos desarrollado grandes habilidades y contábamos con todo lo necesario para hacer un buen trabajo técnico y hasta algún atisbo de investigación.

Mis compañeros se enojaron mucho cuando dije... *Tecnología 10 – Humanidad 0*. Y así era, la ultra alta tecnología contrastaba con la poca humanidad a la que la misma nos llevó.

Unos años antes a raíz de un accidente de aviación al que sobreviví milagrosamente comencé a acercarme a lo espiritual, lejos de la religión en la que me crié. Así fue que me inicié en Reiki,

Yoga, Meditación, Biodecodificación y estudié el Coaching en todas sus variantes. Y muchas lecturas que me permitieron seguir trabajando como médico pero con una visión holística maravillosa. Esto también me fue alejando sin que me diera cuenta del cotidiano de la UCIP.

Traté sin lograrlo que las cosas fueran diferentes, claro, el raro era yo. Sólo una enfermera se subió a mi carro y entendió mis ideas fuera de tiempo.

El 7 de mayo de 2012, día de mi cumpleaños número sesenta y cuatro no había pacientes en la Sala. Como me tocaba guardia vinieron mi mujer y dos de mis hijos a cenar conmigo y cuando se fueron me dispuse a mirar un rato la TV. Como a las dos de la mañana me despertó un fuerte dolor en el pecho (el famoso retroesternal en corbata) o (pisotón de elefante). Me faltaba el aire así que bajé a la Guardia. El resto es fácil de adivinar, vía central, oxígeno, algunas drogas, ambulancia, sanatorio, nueve horas de cirugía cardíaca para tres by pass, recuperación y...jubilación....!

¿Adónde quiero llegar con este relato...? A intentar que quien lo lea comprenda que la única forma de llevar adelante una buena medicina no puede ignorar que todo es uno. Que la tecnología alejada de la humanidad no sirve y que el ser humano sólo puede ser comprendido desde lo holístico, desde la completitud del SER. Cuerpo, mente, espíritu y emoción.

P.D. Esta es una visión parcial, pasional y desinteresada. Seguramente habrá otras pero el mensaje final es el resumen de más de cuarenta años de atender niños y familias. Lo seguiría haciendo pero ya tengo más ganas de “educar nietos en rigor y disciplina”, permítaseme el chascarrillo.

***Dr. Juan Miguel Cotrofe**

Pediatría y Terapia Intensiva Pediátrica. Médico Especializado en traslado aéreo de pacientes críticos

GOLPE DE CALOR

Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría. Servicio de pediatría.

Residencia de pediatría



Dra. Lorena Dinunzio

Médica de Terapia Intensiva Pediátrica

Dra. Dana Dubny

Pediatra

Dra. Estefanía Leguizamón

Dra. Catalina Micaela Prieto

Residentes de 2° año

Dra. María Luisa Rossi Ortega

Residente de 3° año

Dra. Mariela Pelliza

Residente de 4° año

Sumario

Un golpe de calor -o shock térmico-, es uno de los casos más graves de hipertermia.

Dicha entidad se da en personas sometidas a altas temperaturas ambientales, que experimentan un fracaso, potencialmente letal, del sistema de termorregulación corporal. Y constituye una urgencia médica extrema -porque es a la vez de aparición muy rápida (unos minutos son suficientes) y de evolución fatal (puede ocasionar la muerte en un espacio de tiempo muy breve), si no se trata rápidamente. Es una patología prevenible, de baja frecuencia, pero también infra diagnosticada, de alta morbimortalidad. Su presentación clínica se caracteriza por temperatura corporal $> 40^{\circ}\text{C}$ y disfunción organica múltiple.

Situación clínica

Motivo de consulta: Candela de 10 años de edad, es llevada a la guardia del hospital pediátrico por presentar cefalea y vómitos.

Historia clínica:

Paciente femenina, 10 años de edad, que consulta un día de verano posterior a la colonia de vacaciones (32°C temperatura ambiente) por vómitos y cefalea. Presenta como antecedentes un CVAS de 48 hs de evolución. Con comienzo en el día de la fecha de cefalea continua Holo craneal pulsátil y vómitos, que no cedieron ante metoclopramida. Al examen físico presenta fiebre (39°C), enoftalmos, mucosas secas e intolerancia a la vía oral. Se decide su internación para diagnóstico y tratamiento.

Reflexiones

¿Qué otro dato quisiera recabar en la anamnesis?

¿Diagnósticos presuntivos?

¿Primer medida a tomar con esta niña?

¿Estudios que solicitaría?

Se trata de una paciente cuyo diagnóstico a su ingreso es golpe de calor, con deshidratación e intolerancia a la vía oral, por lo que la primera medida a tomar fue la rehidratación EV con PHP 2500 ml/m² (Na 140 mEq/kg - K 20 mEq/kg), más laboratorio para conocer medio interno y necesidad de corrección de electrolitos. Además, en el interrogatorio se buscaron más datos positivos, como otros síntomas (antecedentes de enfermedad, signo sintomatología presente, por ej: diarrea. Horas de evolución, etc.). La paciente evoluciona favorablemente con egreso hospitalario a las 24 hs.

Introducción

Un golpe de calor -o shock térmico-, es uno de los casos más graves de hipertermia.

Dicha entidad se da en personas sometidas a altas temperaturas ambientales, que experimentan un fracaso, potencialmente letal, del sistema de termorregulación corporal. Y constituye una urgencia médica extrema -porque es a la vez de aparición muy rápida (unos minutos son suficientes) y de evolución fatal (puede ocasionar la muerte en un espacio de tiempo muy breve), si no se trata rápidamente. Es una patología prevenible, de baja frecuencia, pero también infra diagnosticada, de alta morbimortalidad. Su presentación clínica se caracteriza por temperatura corporal > 40 °C y disfunción orgánica múltiple.

La toma de temperatura en el hospital puede no ser confiable, debido a la variabilidad individual de cada paciente. El tratamiento antes recibido, o el uso de fármacos antipiréticos, por lo que se deben tomar como válidos valores de temperatura que varíen entre 38 y 42 °C.

Esta entidad patológica ocurre cuando la temperatura corporal aumenta y se genera un fallo del sistema de termorregulación. Los pacientes cursan con disfunción orgánica múltiple, secundaria a aumento de la temperatura corporal sobre límites incompatibles con la vida y produce la afectación multisistémica que afectará de forma desigual a los diferentes órganos de la economía.

La aparición del golpe de calor está estrechamente relacionada con factores de riesgo tales como: temperaturas altas, humedad alta y ausencia de viento. Ocurre con mayor frecuencia en ambientes con temperaturas mayores a 32 °C, aunque se han detectado casos con 25 °C. Dentro de los factores de riesgo individuales podemos mencionar: fiebre, resfrió común, gastroenteritis, vómitos, deshidratación, obesidad, hipopotasemia, falta de sueño, edades extremas de la vida como personas muy mayores, niños menores de 4 años y especialmente menores de 1 año, sufrir ciertas enfermedades crónicas como patología renal, neurológica, endocrina (por ejemplo diabetes) o enfermedades cardíacas. También el uso de algunos medicamentos puede interferir en la regulación de la temperatura corporal y de los líquidos del organismo como pueden ser los diuréticos o los antihistamínicos.

MECANISMOS DE TERMORREGULACIÓN

La temperatura corporal normal fluctúa varios grados (36,6 y 37,5 °C) durante el día como respuesta a la actividad física, emociones y variaciones de la temperatura ambiente. Es producto de la suma del calor ambiental y el generado por el metabolismo, el cual debe estar regulado para mantener un equilibrio homeostático.

Para mantener la temperatura corporal se ponen en juego los mecanismos de termorregulación, que protegen al cuerpo principalmente contra el exceso de calor.

El calor corporal puede perderse de cuatro maneras:

- ✓ Pérdida de calor por radiación: Nuestros cuerpos normalmente están más calientes que el ambiente por lo tanto se produce un intercambio neto de energía calorífica radiante desde el cuerpo a través del aire hasta los objetos sólidos del entorno más frescos.
- ✓ Pérdida de calor por conducción Implica la transferencia directa de calor a través de un líquido, sólido o gas desde una molécula a otra. Aunque la circulación transporta la mayor parte del calor corporal hacia la periferia, una pequeña cantidad se mueve de forma continua por conducción directamente a través de los tejidos profundos hacia la superficie más fresca.

- ✓ Pérdida de calor por convección: la eficacia de este tipo de pérdida de calor depende de la rapidez con la que el aire cercano al organismo lo intercambia una vez que se calienta. Con un movimiento pequeño del aire o sin él (convección), el aire cerca de la piel se calienta y actúa como una zona de aislamiento, minimizando una pérdida de calor por conducción. Al contrario, si el aire más caliente que rodea al cuerpo es sustituido continuamente por aire más fresco (en un día ventoso o mientras se corre) aumenta la pérdida de calor debido a que las corrientes de convección alejan el calor.
- ✓ Pérdida de calor por evaporación: la evaporación es el principal mecanismo de defensa contra el exceso de calor. Como respuesta a la agresión por calor, las glándulas sudoríparas segregan grandes cantidades de solución salina hipotónica. Cuando el sudor alcanza la piel y se evapora el líquido, se produce el enfriamiento.

El golpe de calor es una situación en la que una persona sometida a altas temperaturas ambientales experimenta un fracaso, potencialmente letal, del sistema de termorregulación corporal. Esta condición puede ser el resultado de una excesiva carga de calor ambiental sumada a una producción de calor metabólico aumentada, o a una falla o inhibición de los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor, o a ambas causas. Inicialmente se produce un estrés térmico con una respuesta de fase aguda y un aumento de las proteínas de shock térmico, posteriormente, se desencadena una cascada inflamatoria que conduce a una respuesta inflamatoria sistémica y disfunción orgánica múltiple. En esta progresión, parece tener un papel fundamental la hipoperfusión esplácnica, con disfunción de la barrera endotelial, producción de radicales libres de oxígeno, hiperpermeabilidad capilar y translocación bacteriana, con liberación de endotoxinas y mediadores inflamatorios (citocinas), así como el efecto directo del aumento de la temperatura central sobre el endotelio vascular, que conduce a alteraciones de los mecanismos de coagulación/fibrinólisis. A temperaturas extremas y tras el fracaso de la termorregulación, existe además un daño celular directo con desnaturalización de las proteínas celulares, ne-

crosis y apoptosis (muerte celular programada), que puede aparecer en los primeros minutos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

El golpe de calor (GC) se caracteriza por una alteración en el estado mental asociada a una alta temperatura corporal, a lo que se agrega piel seca y ruborizada. Es considerado una emergencia médica que puede amenazar la vida, se demostró que el GC podía llevar a daño orgánico múltiple, con hemorragia y necrosis en pulmones, corazón, riñones, hígado, cerebro e intestino.

Dentro de las entidades relacionadas con calor, se incluyen el síncope por calor, calambres por calor, agotamiento por calor y golpe de calor propiamente dicha, siendo esta última la más grave.

Síncope por calor

Se presenta como sensación de debilidad causada por vasodilatación periférica, secundaria a una alta temperatura ambiental.

Calambres por calor

Se refiere a calambres musculares que ocurren durante el ejercicio en ambientes de alta temperatura, en relación con déficit de sal. Generalmente tienen evolución benigna.

Agotamiento por calor

Ocurre cuando el individuo llega a estar deshidratado y débil, frecuentemente con náuseas y vómitos, secundarios a la excesiva sudoración que lleva a perder agua y sal. La depleción de sal, en este cuadro se presenta usualmente cuando una persona no aclimatada se ejercita en un ambiente de alta temperatura y solamente bebe agua. La temperatura corporal puede no estar elevada, y no hay daño tisular.

Golpe de calor

Es causado por la elevación de la temperatura corporal asociada a una falla en el sistema de la termorregulación. Se define como una enfermedad grave causada por temperatura elevada, de cuantía variable definida como una temperatura rectal que excede los 40.6 °C, y anormalidades del sistema nervioso central (SNC) como delirio, convulsiones o coma, que se producen como consecuencia de exposición a calor ambiental (GC clásico) o por ejercicio intenso en ambientes

con temperatura elevada (GC post ejercicio). En base a la fisiopatología de este cuadro, también se ha definido como una forma de hipertermia asociada con inflamación sistémica que lleva a falla orgánica múltiple en la que predomina la encefalopatía.

CUADRO CLÍNICO

Para el diagnóstico de GC deben estar presentes hipertermia y disfunción del SNC, siendo esta última una característica principal del cuadro.

Debemos estar alertas a estos síntomas y consultar con urgencia ante la presencia de:

- Temperatura axilar de 39° o mayor.
- Piel roja caliente y seca, cuando se agota la sudoración.
- Agitación.
- Dolor palpitante de cabeza.
- Vértigos y desorientación.
- Delirios, confusión o pérdida de conocimiento.
- Convulsiones.

La disfunción del SNC usualmente es marcada, pero también puede ser solapada manifestándose sólo como conducta inapropiada o alteración del juicio. Las alteraciones más frecuentes son el delirio o coma y convulsiones, que ocurren principalmente durante el enfriamiento. La disfunción neurológica es atribuida a trastornos metabólicos, encefalopatía metabólica, edema cerebral, isquemia y posiblemente daño cerebral por hipernatremia.

El SNC, principalmente el cerebelo, es muy vulnerable a la injuria por calor, con efectos persistentes.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial en paciente con hipertermia y manifestaciones neurológicas es complejo y extenso. Entre los cuadros a considerar se incluyen:

- ✓ GC clásico versus GC post ejercicio
- ✓ Encefalitis
- ✓ Meningitis
- ✓ Síndrome de distress respiratorio agudo
- ✓ Delirium tremens
- ✓ Cetoacidosis diabética
- ✓ Hipertiroidismo
- ✓ Tormenta tiroidea
- ✓ Enfermedad de Graves
- ✓ Infarto al miocardio

- ✓ Shock séptico
- ✓ Hipertermia maligna
- ✓ Arritmias cardíacas
- ✓ Toxicidad por drogas: anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos, cocaína, alucinógenos, Inhibidores de monoamino oxidasa y salicilatos.
- ✓ Síndrome de shock hemorrágico y encefalopatía.

Tratamiento

Está basado en dos pilares, el sostén de las funciones en falla, particularmente la insuficiencia circulatoria, y la disminución inmediata de la temperatura central. La hipertermia y la lesión isquémica tisular se consideran los dos factores más importantes que influyen en la gravedad de las lesiones orgánicas.

El factor determinante más importante en el resultado de esta patología es el tiempo que los pacientes mantienen la hipertermia, por lo que minimizar la duración y la magnitud de la temperatura central se correlaciona fuertemente con la supervivencia.

En el tratamiento prehospitalario se debe evitar que el niño se encuentre en un ambiente «caliente», despojarlo del exceso de ropa y transferirlo a un lugar sombrío o fresco; por otro lado, se debe controlar la vía aérea, la respiración, la circulación con los líquidos intravenosos, el oxígeno suplementario y la ventilación asistida de acuerdo con lo ya indicado; también aplicar al niño paquetes de hielo en cuello, axilas e ingle para acelerar el enfriamiento por evaporación.

En el servicio de urgencias, según el diagnóstico se hace para la insolación, retiro del niño del ambiente cálido, corrección de la deshidratación y de electrolitos; también, aplicar hielo en el cuello, ingle y axilas; dar rehidratación oral con 0.1% de soluciones isotónicas de cloruro sodio y en casos severos líquidos IV.

Para el «golpe de calor» se debe asegurar la vía aérea, cuidar la ventilación y circulación, administrar oxígeno suplementario y líquidos cristaloides por vía endovenosa; también instituir medidas de enfriamiento agresivas para disminuir la temperatura del niño por 0.2 °C/min hasta lograr una temperatura de 38,5 °C, la refrigeración por evaporación es segura: desnudando al niño y colocándolo en inmersión en agua con hielo

Todo el sistema de emergencia debe apuntar a lograr el objetivo de descender la temperatura central en la primera hora, ya que las disfunciones se instalan rápidamente si no se logra el objetivo de descender la temperatura.

Sin embargo, debe evitarse la corrección excesiva enérgica que obliga a un posterior recalentamiento, con el consiguiente fenómeno de lesión por reperusión; por lo tanto, las medidas de enfriamiento deben suspenderse al alcanzar los 38,5° C; de esta manera, resulta imprescindible contar con un registro de temperatura rectal o central.

El monitoreo continuo de la temperatura rectal constituye el patrón de referencia, debido a su accesibilidad, pese a que sus valores son levemente más altos que los de la temperatura sanguínea y su respuesta es más lenta a los cambios que el registro esofágico.

Las técnicas de disminución de la temperatura tienen como objetivo acelerar la transferencia de calor desde la piel hacia el ambiente sin comprometer el flujo sanguíneo cutáneo y evitar la corrección excesiva intempestiva.

El enfoque terapéutico recomendado para el compromiso hemodinámico está basado en el aporte de volumen. La reposición debe hacerse con solución salina isotónica al 0,9%, dado que las soluciones de Ringer lactato pueden aumentar la disfunción hepatocítica. Puede ser útil colocar algún tipo de monitoreo hemodinámico invasivo.

No hay fármacos que aceleren la pérdida de calor y los agentes antipiréticos están contraindicados, ya que el paracetamol puede llevar a falla hepática y el ácido acetilsalicílico puede provocar alteraciones de la coagulación, lo que puede incluso aumentar la mortalidad.

Es importante evitar los escalofríos, porque aumentan la producción de calor y, si aparecen, están indicadas pequeñas dosis de clorpromazina o diazepam.

Es necesario el apoyo de la Unidad de Cuidados Intensivos en todas las complicaciones que sufren los pacientes con golpe de calor. Si es preciso, se procederá a realizar la intubación endotraqueal y la posterior conexión a ventilación mecánica. Se debe tener presente que la potasemia inicialmente baja, luego puede elevarse por la insuficiencia renal y la rabdomiólisis.

PREVENCIÓN

Las enfermedades que tienen relación con el calor son evitables, es por esto importante identificar a los grupos de población susceptibles con objeto de adoptar las siguientes recomendaciones:

Extremar la vigilancia de los niños pequeños, especialmente los menores de un año, de aquellas personas que sufran alguna enfermedad crónica que dificulte sudar (como la fibrosis quística), o de quienes estén tomando determinados medicamentos como, por ejemplo, los antihistamínicos.

- ✓ No esperar a que los niños pidan agua.
- ✓ Ofrecer continuamente líquidos (agua o jugos naturales).
- ✓ En el caso de lactantes ofrecer el pecho de manera más frecuente.
- ✓ No ofrecer bebidas con cafeína o azúcar en exceso.
- ✓ No ofrecer bebidas muy frías.
- ✓ No ofrecer líquidos o comidas calientes o pesadas.
- ✓ Modificar la actividad física según las condiciones ambientales, evitando el ejercicio más intenso en las horas de máximo calor. A esas horas, proponer juegos tranquilos evitando que los niños se agiten.
- ✓ En caso de temperaturas altas, recordar siempre utilizar ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros o, mejor aún, dejarlos sin ropas.
- ✓ Proteger la cabeza de los niños con una gorra. Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.
- ✓ Evitar que los niños permanezcan mucho tiempo expuestos al sol y a altas temperaturas, manteniéndolos en lugares sombreados, bien ventilados o con aire acondicionado.
- ✓ Nunca deje a un niño solo, ni tampoco permanezca con él, dentro de un vehículo estacionado y cerrado.
- ✓ Incorporar sal en mayor cantidad que lo habitual.
- ✓ Proponer actividades tranquilas, evitar juegos intensos.
- ✓ Evitar que transiten y jueguen expuestos al sol, menos aún al mediodía o en las primeras horas de la tarde.
- ✓ Si deben estar bajo el sol, ponerles som-

brero, usar protectores solares (factor 15 o mayor) y tomar frecuentes descansos a la sombra.

- ✓ Procurar que permanezcan en los lugares más frescos y ventilados.
- ✓ Para jóvenes y adolescentes
- ✓ No es conveniente tomar bebidas con alcohol (incluida la cerveza) ante la sed y el calor, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.
- ✓ Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.
- ✓ Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

COMPLICACIONES

- ✓ Cardiovasculares: taquicardia, hipotensión, CPK (Mb) elevada, hemorragia subendocárdica; Pulmonares: edema pulmonar, aspiración, alcalosis y SDRA;
- ✓ Renales: rabdomiolisis, falla renal aguda y CID;
- ✓ Neurológicas: déficits, hemiplejia, coma, demencia, cambios de la personalidad;
- ✓ Hepáticas: ictericia, necrosis hepatocelular y falla hepática;
- ✓ Hematológicas: coagulopatía, así como también la pérdida de electrolitos que da lugar a hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipernatremia, hipoglucemia, hiperuricemia y acidosis láctica.

Bibliografía

- Contreras E, Avaria B. Golpe de calor. *Rev. Ped. Elec.* 2005, Vol 2, N° 1. ISSN 0718-0918. Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil.
- Elmo M. Los riesgos de los días de calor. *Arch. argent. Pediatr* 2003; 101(5) / 424
- Pinacho-Velázquez J. Golpe de calor. Trabajo de revisión *Rev Mex Pediatr* 2014; 81(3); 115-119
- SAP. Campus virtual. Golpe de calor.
- YiC M, Daniel GinDel, Julio Pontet, Mario CanCela. Golpe de calor, *Revista Argentina de Terapia Intensiva*. 2016-33 N° 41
- Yoram Epstein, Ran Yanovich. Revisión y conocimiento actual del golpe de calor y su relevancia en el entorno médico". *New England Journal of Medicine* 2019; 380:2449-59.

VULVOVAGINITIS INFANTIL

Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson de San Martín.
Residencia de Pediatría



Dra. Daniela B. Filippo

Jefa de Servicio

Dra. María Luisa Rueda Puelles

Sub Jefa de Servicio

Dra. Lorena Inés Giménez

Instructora de Residentes

Dra. Julieta Priscila Pastorino

Dra. María Eugenia Frías

Residentes de 4º año

Sumario

La vulvovaginitis se considera la patología ginecológica más frecuente en niñas prepuberales, constituyendo el 25 % de las consultas en ginecología pediátrica. Las causas más frecuentes de vulvovaginitis son la pobre ó excesiva higiene y los irritantes químicos. Generalmente, el cuadro mejora con medidas de higiene y educación a los cuidadores y a la niña.

Situación clínica

Motivo de consulta:

Paciente de sexo femenino de 5 años de edad, consulta a la guardia por presentar prurito y ardor en región vulvar acompañado de flujo maloliente de 48 hs de evolución.

Antecedentes personales:

Embarazo no controlado. RNTPAEG 38 semanas de edad gestacional. PPN normales. Desarrollo psicomotor normal. Vacunación incom-

pleta. Hacinamiento familiar y medidas básicas insatisfechas. Antecedentes de dermatitis atópica en seguimiento por servicio de dermatología infantil e infecciones en piel a repetición, sin otros antecedentes de relevancia.

Al interrogatorio madre refiere medidas de higiene adecuadas, pero por cuestiones económicas cambió el tipo de jabón con el que se baña la niña en la última semana. Destaca que nota prurito perianal y vulvar predominantemente nocturno hace una semana que lo asoció al cambio de jabón. No refiere episodios similares.

Examen físico

BEG, afebril, hemodinámicamente compensada. Abdomen, blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias. Pulsos femorales presentes y simétricos. No adenopatías inguinales. Piel seca, hiperqueratosis regional con dermatitis flexural. A nivel genital se obser-

va: eritema a nivel de labios mayores y menores, acompañado de escoriaciones aisladas lineales compatibles con rascado en labios mayores, y varias erosiones superficiales menores de 0.5 cm en labios menores. Presenta secreción vaginal de aspecto homogéneo sin sangrado. Zona perianal con ligero eritema.

¿Qué es la Vulvovaginitis?

La vulvovaginitis se considera la patología ginecológica más frecuente en niñas prepuberales, constituyendo el 25 % de las consultas en ginecología pediátrica. Las causas más frecuentes de vulvovaginitis son la pobre o excesiva higiene y los irritantes químicos. Generalmente, el cuadro mejora con medidas de higiene y educación a los cuidadores y a la niña.

Se define vulvitis a la inflamación vulvar aislada, mientras que el término vaginitis se refiere a la inflamación vaginal acompañada de flujo. Estas situaciones suelen combinarse, produciendo lo que se conoce como vulvovaginitis (VV).

Fisiopatología

Uno de los factores predisponentes que favorecen a esta patología en edades prepúberes es la anátomo fisiología del aparato genital femenino. El estrógeno estimula la actividad fagocitaria de macrófagos, aumenta la adherencia bacteriana y genera glucógeno y ácido láctico. La recién nacida tiene la vagina estrogenizada, con una secreción mucosa abundante en glóbulos rojos, durante 2-3 semanas. Convirtiéndose luego en un epitelio hipoestrogénico hasta el desarrollo puberal, haciendo a la mucosa vaginal susceptible a la infección. Esta mucosa se caracteriza por ser delgada, con poco epitelio estratificado y pH alcalino siendo más sensible a la invasión por patógenos.

Otros factores predisponentes en niñas son el escaso desarrollo de los labios mayores y menores, la ausencia de vello pubiano, la presencia de un himen delgado y amplio lo que conlleva a una menor protección del introito vaginal. También predisponen la anatomía perineal (cercanía entre el recto y la vulva), los malos hábitos higiénicos, el juego (juegos en arena y tierra) así como condiciones personales: sobrepeso, dermatitis vulvar y la sinequia de labios menores.

Etiología

Según los agentes etiológicos causales, las vulvovaginitis se clasifican en específicas e inespecíficas.

Las VV inespecíficas

Se caracterizan por malos hábitos higiénicos, irritantes locales, cuerpos extraños y flora mixta bacteriana constituida por los gérmenes habituales de la vagina, que en algunos casos puede mostrar algún organismo predominante. Representan el 60-70% de las VV en la etapa prepuberal y el resto corresponde a la VV específicas. Durante la pubertad, con la iniciación de la secreción ovárica de estrógenos, esta relación se invierte.

Flora Habitual:

En Lactantes y preescolares predomina la flora mixta. Con predominio de gérmenes entéricos E.Coli, Diphteroides, Bacteroides, Staphylococcus, Streptococcus

Gérmenes Aerobios: Staphilococcus Epidermidis Enterococcus Escherichia Coli Lactobacilos Streptococcus Viridans

Germenes Anaerobios: Peptococcus Peptostreptococcus Vellonela Bacteriodes Propionibacterium Otros Proteus Mirabilis Pseudomonas Cándida Albicans

Las VV específicas

Son causadas por agentes patógenos específicos, generalmente único, que no forman parte de la flora habitual de la vagina. Por ejemplo oxiurias, microorganismos de la flora entérica o respiratoria (S.pyogenes, S. aureus, H. influenzae, etc.), bacterias causantes de ITS (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HPV, etc.), candida. Las VV específicas en las que se aísla un agente etiológico específico causante de los síntomas, pueden haberse transmitido por patógenos fecales o respiratorios. Estos organismos pueden transmitirse a la niña por el uso incorrecto del papel higiénico y de forma manual desde la nasofaringe hasta la vagina.

Agentes etiológicos VV en niñas prepúberes

- ✓ Estreptococo B hemolítico grupo A (59 %)
- ✓ Haemophilus influenza
- ✓ Estaphilococcus aureus
- ✓ Moraxella Catarralis

- ✓ *Streptococcus Neumoniae*
- ✓ *Shigella Flexneri*
- ✓ *Neisseria Gonorrhoeae Trichomona*
- ✓ Abuso sexual ETS: *Chlamydia Trachomatis* HSV/ HPV
- ✓ Cuerpos extraños Oxiuros Enfermedades generalizadas Dermatitis
- ✓ Entre las causas de VV recidivantes se encuentran las Parasitosis y los cuerpos extraños frecuentemente.

Manifestaciones clínicas

VV inespecífica:

Típicamente, en estas vulvovaginitis el flujo es mucoide, no purulento, de pequeña cuantía e inodoro. Presentando en ocasiones eritema y prurito vulvar.

VV específicas:

Flora entérica o respiratoria: En ocasiones, las niñas pueden pasar flora respiratoria desde la nariz o la faringe al área vulvar. Los patógenos respiratorios que producen esta patología incluyen *S. pyogenes*, *S. aureus*, *H. influenzae*, *S. pneumoniae* o *Neisseria meningitidis*. Aunque inicialmente se consideró al *H. influenzae* como la bacteria más frecuentemente implicada en estos casos de vulvovaginitis bacteriana específica, la introducción de la vacunación universal frente a este germen ha hecho que en los últimos años el *S. pyogenes* sea el responsable de la mayoría de vulvovaginitis bacterianas específicas. La mitad de las niñas afectadas por esta bacteria tienen historia personal o familiar de faringoamigdalitis, previsiblemente causada por este patógeno, aunque en ocasiones también se han implicado serotipos de *S. pyogenes* causantes de impétigo y no de amigdalitis. Generalmente se presenta de forma súbita, con flujo seropurulento, prurito, disuria, eritema e inflamación vulvar. También se han descrito cuadros de vulvovaginitis causados por gérmenes entéricos como *Shigella* sp. o *Yersinia* sp., que suelen producir un flujo vaginal mucopurulento frecuentemente acompañado de diarrea. Por tanto, y para investigar la etiología específica del cuadro, se deben obtener estudios microbiológicos en casos de flujo vaginal persistente o purulento, y la antibioterapia a utilizar dependerá del organismo aislado.

Aunque la vulvovaginitis por *Candida* es rara en



la niña prepúber, la colonización por esta levadura ocurre en un 3-4% de las niñas y debe sospecharse una etiología candidiásica ante la presencia de leucorrea no maloliente con prurito en edad puberal, especialmente en niñas con factores de riesgo (inmunosupresión, tratamiento antibiótico reciente, diabetes, etc.). También es frecuente la dermatitis del pañal sobreinfectada por *Candida* en niñas que usan todavía pañales, que cursa con el característico rash perineal eritematoso, con lesiones satélites.

Enfermedades de transmisión sexual

Algunas infecciones de transmisión sexual se pueden presentar con flujo vaginal aumentado, y típicamente son secundarias a abuso sexual. Los gérmenes más frecuentemente implicados son: *Neisseria gonorrhoeae* (2,8%), *Chlamydia trachomatis* (1,2%), virus del papiloma humano (VPH) (1,2%), *Treponema pallidum* (0,1%) y *Herpes simplex* (0,1%). La VV gonocócica raramente es asintomática y se presenta generalmente con un flujo profuso, inodoro, verde-mucoso. En casos más graves, y generalmente en mujeres adolescentes con actividad sexual, se puede manifestar como enfermedad pélvica inflamatoria, uretritis o endocervicitis. En todas las niñas prepúberes que hayan superado el periodo neonatal (donde la infección puede tener un origen vertical), y en las adolescentes sin actividad sexual que presenten una infección gonocócica, debe considerarse que se ha producido abuso sexual a menos que se demuestre lo contrario,

aunque excepcionalmente se han descrito casos de enfermedad gonocócica por exposición doméstica al germen. El diagnóstico de una vulvovaginitis por gonococo debería inducir a investigar otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la hepatitis B, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, o la infección por *C. trachomatis*. Esta infección es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en adolescentes, y puede provocar vulvovaginitis poco sintomática en niñas prepúberes víctimas de abuso sexual. No hay que olvidar que la infección asintomática adquirida en el momento del parto en hijas de madres portadoras puede persistir hasta tres años.

Las **infecciones por *Trichomonas vaginalis*** suelen ser asintomáticas, pero pueden producir VV con flujo vaginal amarillo pálido, grisáceo o verdoso, en ocasiones con hemorragias puntiformes en la vagina y el cuello del útero que también deben sugerir abuso sexual si se presentan en niñas prepúberes.

Los **virus Herpes simplex 1 y 2** también pueden producir enfermedad genital. Aunque la transmisión perinatal se ha descrito como causa de herpes genital en la infancia, la infección ocurre principalmente tras contacto sexual, lo cual debe ser investigado en niñas prepúberes. Clínicamente cursa con prurito vaginal, disuria y dolor local, objetivándose vesículas agrupadas con base eritematosa como hallazgo fundamental.

El **virus del papiloma humano VPH** también puede producir lesiones vulvovaginales (condiloma acuminado o verrugas genitales). Aunque en niños de dos o tres años de edad las lesiones pueden ser secundarias a transmisión vertical durante el parto vaginal y se han descrito casos de transmisión mediante fómites, esta infección

también es una enfermedad de transmisión sexual.

Oxiuriasis

Aunque los oxiuros no residen en la vulva, las hembras dejan sus huevos en la zona perianal durante la noche y pueden ascender desde el ano al introito vulvar y causar intenso prurito nocturno. Las niñas con episodios recurrentes de prurito perianal o vulvar, especialmente nocturno, deben ser estudiadas para descartar esta infestación parasitaria.

Cuerpo extraño

Los cuerpos extraños vaginales en niñas pueden causar VV aguda o crónica. Esta causa flujo vaginal crónico maloliente, y en ocasiones sangrado. Restos de toallitas o papel higiénico son los cuerpos extraños más comúnmente aislados en estas niñas, aunque en ocasiones se encuentran otros objetos como monedas, tapones de botellas o pequeños juguetes.

Miscelánea

En raras ocasiones, un flujo vaginal persistente, generalmente asociado a sangrado, puede indicarnos la presencia de un pólipo benigno en la vagina, o lo que es más infrecuente y grave, un tumor maligno (rabdomiosarcoma o sarcoma botrioides) que afecte al himen, a la uretra distal o a la pared anterior de la vagina. En enfermedades sistémicas como la rubéola, la varicela, el sarampión, la escarlatina, la mononucleosis por virus de Epstein-Barr, la enfermedad de Crohn o la de Kawasaki, también pueden presentarse signos y síntomas vulvovaginales como vesículas, fístulas, úlceras o inflamación. Tampoco hay que olvidar que existen malformaciones urinarias, como son el uréter ectópico o el prolapso

Microorganismos causales		
Edad	Frecuentes	Menos Frecuentes
Niña Prepuberal	Flora mixta (y factores irritantes locales, mala higiene)	EBHGA (<i>Streptococcus pyogenes</i>) <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Shigella</i> Oxiuros Otras causas no infecciosas: cuerpo extraño intravaginal
Pubertad y adolescencia	<i>Candida albicans</i>	Vaginosis bacteriana <i>Trichomona vaginalis</i>

uretral, que en ocasiones producen irritación vulvar persistente.

Gérmenes relacionados con ASI

- Categoría 1: sin datos
- Categoría 2 Abuso posible:
Vulvitis, lesiones x rascado, aumento de vascularización del introito, coalescencia de labios menores, flujo vaginal, condilomas en menores de 2 años, hiperpigmentación anal.
- Categoría 3 Abuso probable:
Presencia de gérmenes de transmisión sexual: Trichomonas, clamidia en mayor de 3 años, HVS 2, HVS 1, condilomas en mayores de 2 años, condilomas anales.
- Categoría 4 Certeza de abuso
Cultivos + Neisseria, serología + sífilis o HIV descartada la transmisión vertical
Ausencia de lesiones o infección NO DESCARTA ASI

Fuente: Protocolo ASI www.sagij.org

Diagnóstico de VV

1) Interrogatorio

Anamnesis en ambiente adecuado
Síntomas concomitantes o patologías previas (respiratorias, digestivas, piel)
Antecedentes ginecológicos: flujo, polaquiuria, ardor vulvar, disuria, prurito, hemorragia, hábitos masturbatorios,
Hábitos de aseo
Síntomas concomitantes o patologías previas (respiratorias, digestivas, piel, parasitosis)

2) Examen Físico

- General: aspecto general, lesiones y síntomas asociados.
- Genital: Inspección de labios mayores y menores. Sinequias Introito Himen Uretra Ano.
Eritema vulvar ó vulvo anal
Características de flujo
Lesiones agregadas (úlceras,pápulas,pústulas, condilomas)

3) Estudios complementarios

Laboratorio:
Exudado Vaginal Directo: Aminas.Test Gram. Cultivo. PCR
Recolección de muestra:
En pacientes vírgenes: toma con hisopo hume-

decidos en solución fisiológica: Instilar sol. fisiológica y aspiración con sonda.

En pacientes no vírgenes: toma con espéculo -endocervix -uretra

Cultivos: Flora patógena cuando encuentre exagerada colonización de 1 o 2 tipos de gérmenes sobre el resto + leucocitos y/o piocitos.

Examen Coproparasitológico con Test Graham
Opcional: Urocultivo. Coprocultivo

Imágenes

Radiografía ó ecografía pelviana ante sospecha de cuerpo extraño.

Vaginoscopía

Visualización del cuello y la vagina en niñas pequeñas.

Efectuado por especialista. Requiere sedación.

Vaginoscopios infantiles Huffman, Capraro

Indicaciones: vulvovaginitis recidivantes, cuerpo extraño, hemorragia de origen no hormonal sin causa definida

Características generales para el diagnóstico de VV

Vulvovaginitis Inespecífica

- ✓ Dos o más factores de riesgo
- ✓ Cultivo: Ausencia de gérmenes, flora comensal entérica, leucocitos
- ✓ Síntomas solapados
- ✓ Vulvovaginitis Específica
- ✓ Gérmenes patógenos: Respiratorios / Entéricos /Transmisión sexual
- ✓ Más sintomáticas
- ✓ Agudas
- ✓ Larga evolución

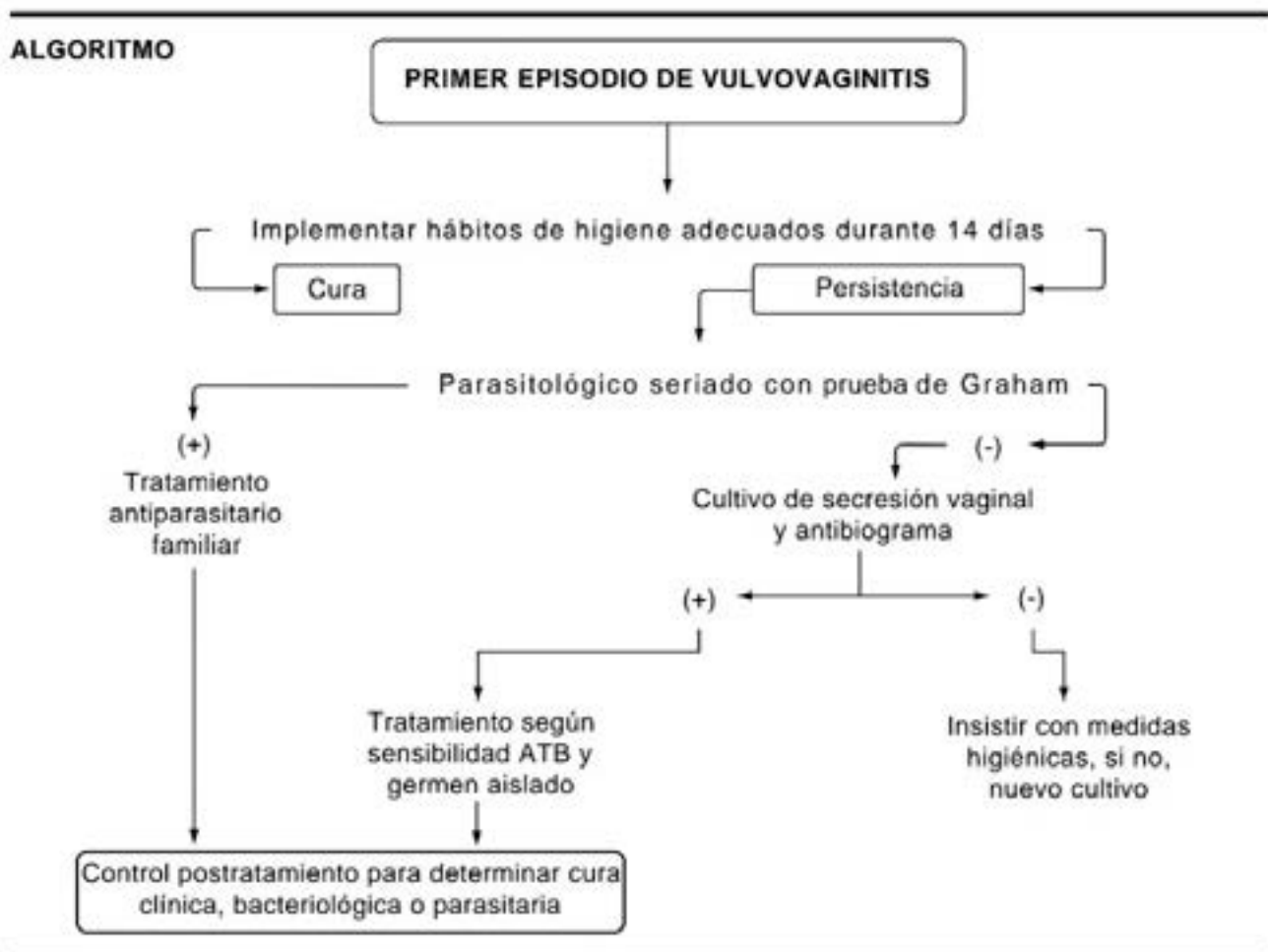
Tratamiento de VV

Medidas generales

- ✓ Uso de ropa interior de algodón
- ✓ Lavado de genitales con jabones neutros
- ✓ Técnica de limpieza perineal adecuada evitando el arrastre de gérmenes de la zona anal a vulvar
- ✓ No compartir toallas ni ropa interior
- ✓ Evitar el baño de inmersión, el bidet y el empleo de esponjas

Medidas locales

- ✓ Durante el episodio agudo, baños de asiento descongescivos con agua de malva



ó manzanilla en un litro de agua hirviendo, dejar enfriar y colar (5 a 10 minutos dos veces por día)

- ✓ En la etapa subaguda, de persistir la inflamación y el prurito, colocar cremas locales (con antibióticos y antiinflamatorios, no más de 10 años)
- ✓ Medicación antibiótica intravaginal, de excepción en casos de VV crónicas ó recidivantes
- ✓ Medicación sistémica
- ✓ Tratamiento específico de la oxiuriasis
- ✓ Antibiótico por vía oral en caso de un germen predominante asociado a reacción inflamatoria en el exámen bacteriológico y de acuerdo a la sensibilidad antibiótica por antibiograma
- ✓ Excepcionalmente en VV crónicas ó hemorrágicas, estrógenos de acción selecti-

va en tracto genital inferior(estriol) ó por vía oral 500-1000 ug/día de 10 a 15 días

Extracción de cuerpo extraño por vaginoscopía. Antibioticoterapia profiláctica (amplio espectro)

Posteriormente estriol por vía oral para favorecer la reepitelización 10-15 días.

Tratamiento de VV inespecíficas

- Hábitos de higiene
- Tópicos locales con hidrocortisona
- Pro bióticos
- Infecciones específicas
- Corrección del factor condicionante

Tratamiento VV específicas

- Tratamiento específico según la causa
- Corrección del factor condicionante
- Tratamiento específico según la causa

	Situación Clínica	De elección	Alternativas
	Cuadros leves inespecíficos (Flora mixta bacteriana)	No precisa tratamiento antimicrobiano, sólo medidas higiénicas: enseñar y revisar la técnica correcta de limpieza de los genitales después de orinar o defecar (de delante hacia detrás), evitar el uso de ropa ajustada (mallas, leotardos), usar ropa interior de algodón, no utilizar jabones perfumados o irritantes para limpiar la zona genital. Baños diarios con agua tibia durante 10-15 min, secar completamente la zona después del baño. Dormir si fuera posible con camisón mejor que con pijama y evitar el uso de suavizantes en la ropa interior y bañadores	En casos con sintomatología persistente o empeoramiento se puede valorar hasta recibir el resultado del cultivo tratamiento empírico dirigido a EBHGA y Hib: Amoxicilina / clavulánico (presentación 4:1 250mg/5ml) 40 mg/kg/día (de amoxicilina), en 3 dosis, durante 7-10 días, VO
Infecciones específicas	EBHGA	Penicilina V; dosis: 250 mg/12 horas si <12 años y 500 mg/12 horas si >12 años de edad; durante 10 días, VO	Amoxicilina, 50 mg/kg/día, en 2-3 dosis, durante 10 días, VO Si alergia a beta-lactámicos: - Inmediata o tardía grave: Josamicina 30-50 mg/kg/d q12h o Midecamicina 30-50 mg/kg/d c/ 12h Clindamicina 20-30 mg/kg/d c/8h - Tardía no grave: Cefuroxima-axetilo 15 mg/kg/d c/12h Cefadroxilo 30 mg/kg/d c/12h
	H. influenzae tipo b	Si no productor de beta-lactamasa según antibiograma: Amoxicilina 50 mg/kg/día, en 2-3 dosis, durante 10 días Si productor de beta-lactamasa o fracaso terapéutico: Amoxicilina / clavulánico (presentación 4:1 de 250mg/5ml) 40 mg/kg/día (de amoxicilina), en 3 dosis, durante 10 días, VO	Alergia a beta-lactámicos: - Azitromicina 10-12 mg/kg/d 3-5 días
	Shigella	Trimetoprim-sulfametoxazol 10/50: 6 mg/kg/día, 2 dosis, 5 días. VO. Cefixima 8 mg/kg/día, 5 días. VO	En casos resistentes: Azitromicina 12 mg/kg/día 3-5 días VO Ceftriaxona 50-75 mg/kg/día en 1-2 dosis, 2-5 días, IM o IV
	Oxiurias	Mebendazol 100 mg o pamoato de pirantel 10mg/kg; dosis única, VO (y repetir a las 2 semanas)	
	Candida albicans	Vía oral y vaginal tienen una eficacia similar Fluconazol oral (dosis única de 150 mg) Clotrimazol crema tópica 1% 2-3 aplic/d en labios y zonas adyacentes 7-14 días, o crema 2% intravaginal en > 12 años 1 aplicación diaria durante 3 días (7-14 días si complicada) Clotrimazol óvulo de 500 mg dosis única en >12 años	Itraconazol (200 mg, c/12 horas, 1 solo día), VO Clotrimazol óvulo vaginal de 100 mg, 1 al día por 7 días o c/12 hs durante 3 días Miconazol crema intravaginal: 1 aplic/día 7 días
	Vaginosis bacteriana	Metronidazol 500 mg cada 12 horas, 7 días. VO Metronidazol óvulo vaginal, una vez al día, durante 5 días	Clindamicina 300 mg, 2 dosis al día, 7 días. VO. Clindamicina óvulos vaginales 100 mg, 1 al día, 3 días Clindamicina 5 g crema intravaginal, 7 días.

Tratamiento específico según etiología

Prevención de vulvovaginitis

- ✓ Promover hábitos de higiene adecuados
- ✓ Educación en el autocuidado: evitar irritantes locales como ropa interior apretada, baños de espuma, jabones perfumados.
- ✓ Evitar sobrepeso
- ✓ Ropa interior de algodón
- ✓ Controles periódicos de salud.
- ✓ Evitar baño de ducha vaginal
- ✓ Educación sexual: Promover uso de métodos de barrera en adolescentes

Conclusiones

Los problemas ginecológicos pediátricos, especialmente aquellos que involucran el área vulvar, son comunes en la infancia. La VV supone el problema ginecológico más frecuente en las niñas prepúberes, debido a una serie de factores predisponentes. Recordar que el 75% VV en prepúberes son inespecíficas y en púberes 80% son VV específicas. En las VV específicas en prepúberes buscar antecedentes respiratorios, digestivos y ASI. En VV recidivantes pensar en parásitos, cuerpo extraño en vagina. Trabajar hábitos sexuales en púberes y estimular uso preservativo y trabajar en la pareja sexual.

La mayoría de casos de VV son leves y responden correctamente al tratamiento con medidas generales, sin ser necesaria la realización de pruebas complementarias.

En casos de mala evolución o sintomatología grave, está indicada la realización de pruebas microbiológicas y el tratamiento específico del microorganismo causante.

Otras afecciones que se ven con frecuencia incluyen VV bacteriana recurrente, irritación vulvar, adherencias labiales y afecciones dermatológicas.

Finalmente recordar que uno de los aspectos más importantes respecto a la VV es la prevención, con adecuadas medidas de higiene y considerar siempre como diagnóstico diferencial el Abuso sexual infantil entre las probables etiologías.

Bibliografía

- 38º Congreso Argentino de Pediatría.
- Comité Nacional de Endocrinología. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de vulvovaginitis (VV) en niñas prepúberes. Arch. Argent. Pediatr. 2000;(6:412)
- Kliegman, R. Capítulo 549:Vulvovaginitis.Nelson Tratado de Pediatría. 20 Edición. Elsevier, año 2016.
- López Nieves M., Plaza Almeida J. Revisión de vulvovaginitis, a propósito de un caso. AEPap. 2019
- Ortiz Movillaa, B. Acevedo Martín. Guía rápida para la selección del tratamiento antimicrobiano empírico [2019]. Revisiones, Vulvovaginitis infantil. Vol. XIII. N.º 52. Revista Pediatría de Atención Primaria. 2011; 13:601-9.
- Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. Protocolo de Abuso Sexual infantil ASI.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

Hospital de Niños Debilio Villegas de Tandil



Dra. Nadia Bocon

Dra. Sofía Mores

Residentes 1° año

Dra. Estefanía Ortigosa

Residente 2° año

Dra. Josefina Rodríguez Eyra

Dra. Nereida Figueiredo

Residentes 3° año

Dra. Karina Espada

Residente 4° año

Dra. Mercedes Zubigaray

Jefa de residentes

Dra. Ileana Mastropierro

Instructora de residentes

Dra. Florencia Bruggesser*

Revisora

Sumario

La fiebre es un síntoma común en los niños, ocasiona un tercio de las consultas en pediatría, generando ansiedad y preocupación en el paciente, su familia y el personal médico tratante.

En un gran porcentaje de los casos suele ser causada por infecciones benignas virales o bacterianas con un foco claro, que se diagnostican en base a la anamnesis y examen físico.

Sin embargo, en ocasiones, los cuadros febriles se prolongan por más de 7 días transformándose en fiebre prolongada (FP). Si a pesar de un correcto estudio no se logra reconocer la causa de la fiebre, el cuadro se convierte en una fiebre de origen desconocido (FOD).

Caso clínico

Paciente masculino de 9 años sin antecedentes de relevancia que se interna por fiebre de 9 días de evolución, asociada a astenia y dolor abdominal. Al examen físico en el ingreso, presenta regular estado general, palidez cutánea, fauces congestivas y pequeñas adenopatías cervicales

e inyección conjuntival. Auscultación respiratoria y cardíaca normal, abdomen blando, con dolor en epigástrico y supraumbilical, no se palpa hepatomegalia ni esplenomegalia, articulaciones libres y móviles, no dolorosas. Peso: 27.500 (PC 25-50), talla: 1.34 mts (PC 50-75), IMC: 15.3 (DS 0/-1).

Se solicita laboratorio GB 13350/mm³ (65%*s*N/29%*L*), ERS 38 mm/h, PCR 6 mg/dl, Glu 90 mg/dl, urea 27 mg/dl, creatinina 0.7 mg/dl, LDH 381 mIU/ml, plaquetas 241000/mm³, amilasa 38 mUI/ml, lipasa 27 mIU/ml, TGP 38 mUI/ml, TGO 54 mUI/ml, FAL 204 mUI/ml. Ferritina, dosaje de inmunoglobulinas, anti DNA y complemento normales. Monotest negativo, orina completa normal, urocultivo y hemocultivos x 2 negativos. Ecografía abdominal: esplenomegalia bazo de 113 mm. (VN entre 8- 10 años: 100-110mm), hígado, riñones y páncreas de tamaño y ecoestructura habitual. Fondo de ojo, ecocardiograma y estudio hematológico normales.

Evoluciona febril persistente, con astenia, anorexia, sin pérdida de peso, con desmejoría de

parámetros de laboratorio, ERS 80 mm/h y PCR 34 mg/dl.

A los 18 días de fiebre se repite ecografía abdominal, la cual muestra hígado con varias imágenes pseudonodulares hipoecogénicas de márgenes mal definidos (la mayor de 9,5 mm). Bazo mide 104 mm en su eje mayor, de contornos lobulados con imágenes nodulares hipoecogénicas, la mayor con márgenes mal definidos de 20 mm de diámetro. Se observan imágenes nodulares compatibles con ganglios aumentados de tamaño en el hilio hepático, adyacentes al tronco celíaco y a los vasos ilíacos primitivos derechos y a nivel mesentérico/ retroperitoneal prevertebral.

Se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis, hígado presenta imágenes pseudonodulares hipodensas sin otras alteraciones. La mayor mide aproximadamente 1 cm de diámetro. Bazo de contornos ligeramente lobulados. Mide aproximadamente 92 mm en su eje mayor. Presenta, al menos, una imagen nodular hipodensa mal definida de aproximadamente 12 mm. No se descarta la presencia de imágenes nodulares aumentadas de tamaño en el retroperitoneo prevertebral, a nivel mesentérico y adyacentes a la cadena iliaca primitiva derecha.

Se realizan serologías IgM e IgG CMV, EBV y toxoplasmosis negativos, ELISA VIH negativo, radiografía de tórax normal. Hemocultivos seriados negativos.

En el reinterrogatorio surge antecedente epidemiológico de contacto con gato bebé, 2 meses previos al inicio de los síntomas, presentando en dicho momento cuadro de conjuntivitis y adenitis unilateral.

Se solicita serología IgM positivo para *Bartonella Henselae*.

Con dicho resultado se realiza tratamiento con trimetoprima-sulfametoxazol + rifampicina por 14 días, y 5 días de azitromicina, con mejoría de parámetros de laboratorio y resolución de imágenes luego de 2 meses.

Introducción

La fiebre es un síntoma común en los niños, ocasiona un tercio de las consultas en pediatría, generando ansiedad y preocupación en el paciente, su familia y el personal médico tratante. Los niños mayores generalmente toleran mejor los cuadros febriles y en la adolescencia

se consulta cuando este síntoma se prolonga o es acompañado de algún malestar significativo, siendo la fiebre un signo acompañante. (6)

En un gran porcentaje de los casos suele ser causada por infecciones benignas virales o bacterianas con un foco claro, que se diagnostican en base a la anamnesis y examen físico, sin necesidad de estudios complementarios, o autolimitándose antes de llegar al diagnóstico. Sin embargo, en ocasiones, los cuadros febriles se prolongan por más de 7 días transformándose en fiebre prolongada (FP). Si a pesar de un correcto estudio no se logra reconocer la causa de la fiebre, el cuadro se convierte en una fiebre de origen desconocido (FOD). (6-7)

La FOD se define como una temperatura mayor a 38° en un período superior a 8 días, luego de haber realizado una completa anamnesis, valoración física y estudios complementarios exhaustivos, sin arribar a un diagnóstico. No existen datos fidedignos acerca de su incidencia. (8)

Es fundamental distinguir la FOD de:

Fiebre sin foco: Síndrome febril agudo sin causa aparente que justifique la fiebre, luego de una anamnesis y examen físico minucioso, en niño que se presentan en buen estado general y sin patología de base.

Fiebre periódica: 3 o más episodios febriles de duración variable, en 6 meses, con intervalos asintomáticos de al menos 1-2 semanas, cuyas causas pueden ser enfermedades conocidas infecciosas, neoplásicas, autoinmunes o autoinflamatorias. (6-7-8)

Es importante, al momento de decidir estudiar a un niño con síndrome febril prolongado, certificar esta condición, debido a que frecuentemente sucede que el paciente presenta cuadros febriles benignos, autolimitados y consecutivos en un periodo de tiempo que puede aparentar ser una fiebre prolongada. (1)

Fisiopatología

La temperatura corporal está regulada por el centro termorregulador del hipotálamo mediante los sistemas pulmonares, cutáneos y metabólico. Además, puede variar según edad, sexo, nivel de actividad, fase del ciclo menstrual, hábitos corporales, etc; y puede variar diariamente con el ritmo circadiano, con un punto más bajo en la mañana y un pico al final de la tarde / noche, llegando a una variación de hasta 1° C. (2-6)

La temperatura normal media generalmente se considera 37° C. Se define fiebre como la temperatura central de al menos 38° C. Es una elevación anormal de la temperatura corporal que se produce como parte de una respuesta biológica específica que está mediada y controlada por el sistema nervioso central. Se considera una parte integral de la respuesta inflamatoria y, como tal, puede desempeñar un papel en la lucha contra la infección. (2)

Es el resultado de una serie de eventos altamente coordinados que comienza periféricamente con la síntesis y liberación de interleucina (IL) -1, IL-6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa y otras citocinas pirógenas endógenas por las células fagocíticas en la sangre o los tejidos. Estas citocinas ingresan a la sangre y son transportadas al hipotálamo anterior, donde inducen un aumento brusco en la síntesis de prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2 (PGE2), la cual aumenta el punto de ajuste hipotalámico para la temperatura corporal. El centro termorregulador reconoce que la temperatura corporal actual es demasiado baja e inicia una serie de eventos para elevar la temperatura corporal al nuevo punto de ajuste y alcanzar el nuevo equilibrio (aumento de la tasa metabólica, la actividad, el tono muscular, y disminución de la perfusión de la piel). (2)

La tasa metabólica aumentada, acelera la movilización del sistema inmunitario, la transformación de linfocitos, la actividad de lisosomas y neutrófilos, y la fagocitosis. (6)

La temperatura corporal elevada puede deberse también a la hipertermia, y es importante diferenciar entre estas condiciones porque tienen diferentes implicaciones clínicas y estrategias de manejo. La hipertermia es una elevación anormal de la temperatura corporal que ocurre sin un cambio en el punto de ajuste termorregulador en el hipotálamo. Esta falla de la homeostasis normal produce una producción de calor que excede la capacidad de disipación del cuerpo. La temperatura corporal en pacientes con hipertermia no responde a los agentes antipiréticos. Las características clínicas incluyen antecedentes de exposición al calor ambiental o uso de medicamentos que interfieren con la termorregulación normal (p. Ej., Anticolinérgicos); piel caliente y seca; y disfunción del sistema nervioso central (p. ej., delirio, convulsiones, coma). (2)

Etiología

La fiebre es un signo de enfermedad subyacente, cuya causa debe evaluarse, especialmente si el niño no se ve bien o si la fiebre persiste. (2)

La fiebre puede obedecer a múltiples causas, en la mayoría de los casos la FOD responde a presentación atípica de enfermedades comunes las tres categorías más habituales por orden de frecuencia en niños son las enfermedades infecciosas, las enfermedades de tejido conectivo y las neoplasias (Tabla 1). Además, hay causas que no se incluyen en estas categorías por ser menos frecuentes, pero es importante tenerlas en cuenta al momento de arribar al diagnóstico, entre ellas pueden ser inmunitarias, neurológicas, genéticas, ficticias e iatrogénicas. (9) (13)

Hay una relación entre la edad y la etiología, es decir, que a menor edad de presentación, mayor probabilidad de que la causa del cuadro febril sea infeccioso, y a mayor edad aumenta la prevalencia de las enfermedades de tejido conectivo, autoinmunes y tumoral. (8)

Cabe destacar, que pueden aparecer nuevos signos o síntomas luego de la primera evaluación, que pueden servir para determinar la etiología, por lo tanto es fundamental realizar una anamnesis detallada y un minucioso examen físico al inicio del cuadro febril con posteriores reevaluaciones, tanto de la anamnesis como del examen físico, a lo largo del proceso de estudio. Es por esto, que una anamnesis o examen físico incompletos, como así retrasarnos en solicitar estudios complementarios necesarios pueden ser una de las causas de la FOD. Es muy importante que el pediatra o el médico de Atención Primaria esté capacitado para realizar un abordaje inicial integral para un diagnóstico precoz y hospitalización en aquellos casos que presenten indicación. (8)

Casi la mitad de los niños previamente sanos menores a 3 años de edad con fiebre, no tienen una fuente infecciosa identificada en el examen físico, pero tienen un riesgo significativo de infecciones bacterianas ocultas como infección del tracto urinario (ITU), bacteriemia oculta o neumonía oculta. Este riesgo aumenta cuando el niño no cuenta con un calendario de vacunación completo. (11)

Causas Infecciosas	Localizadas	Osteomielitis y Artritis Séptica Absceso Intraabdominal Endocarditis Infecciosa Absceso Hepático/Infección Hepática Infección del tracto Urinario Infección Respiratoria/mastoiditis/sinusitis
	Generalizadas	Inf. Viral (CMV, VEB, Adenovirus, Enterovirus, Arbovirus) Virus hepatotropos Enf. Arañazo de Gato Toxoplasmosis/Leishmaniasis/Malaria/Chagas Leptospirosis/Brucelosis/Salmonella/Tuberculosis Inf. fúngicas VIH/Psitacosis Tularemia Fiebre Q Larva Migrans Visceral
Causas No Infecciosas	Reumatológicas	Artritis Idiopática Juvenil (ARJ) Lupus Eritematoso Sistémico Vasculitis
	Autoinmunes	Enf. de Behcet/ de Crohn/Enf. Inflamatoria Intestinal/ Hipertiroidismo
	Neoplasias	Leucemias/Linfomas Tumores sólidos
	Miscelánea	Diabetes Insípida Fiebre Facticia Fiebre medicamentosa Munchausen Pancreatitis Displasia Ectodérmica Disautonomía familiar

Tabla 1. Etiología de FOD.

Diagnóstico

La fiebre es un signo clínico importante. El primer paso en el manejo de la fiebre es determinar su causa. (2)

Para arribar a un diagnóstico, es necesario realizar una anamnesis y examen físico detallados. Inicialmente se debe constatar la fiebre, interrogar sobre el tiempo de evolución de la misma, las características (temperatura máxima, picos diarios, momento del día, si cede con antipirético), manifestaciones acompañantes, cronología de aparición y persistencia de síntomas constitucionales luego de cedida la fiebre (exantemas, algias, dolor articular, diarrea, disuria, cefalea, tos, malestar general), foco epidemiológico relacionado, comorbilidades y enfermedades previas, hospitalizaciones previas, tratamiento farmacológico, antecedentes de inmunizaciones, contacto con mascotas, picaduras de insectos, hábitos alimentarios inusuales (por ej. pica), viajes e historia familiar de enfermedad. Suele ser útil la utilización de calendarios de fiebre, registrando también si existieran síntomas acompañantes. (4-10-12 libro-13)

El examen físico debe ser general, minucioso y ordenado (cefalo-caudal) en lo posible para evitar omisiones, como así también la importancia del registro de los signos vitales y el estado general del niño con y sin fiebre. La discrepancia entre frecuencia cardíaca y temperatura aumenta la probabilidad de una fiebre facticia.

Se debe realizar un examen cuidadoso del tracto respiratorio con inspección de faringes (eritema y/o exudado), otoscopia y examen oftalmológico, búsqueda de rinorrea purulenta y auscultación pulmonar. En el niño mayor se debe examinar los senos maxilofaciales y la cavidad bucal, evaluar la lengua, mucosa oral, los dientes en búsqueda de caries y enfermedad periodontal. Un soplo cardíaco nuevo puede constituir un indicio de fiebre reumática o endocarditis infecciosa. El hallazgo de adenopatías, especialmente si son generalizadas puede hacer sospechar una infección viral (ej, mononucleosis, CMV, toxoplasmosis, HIV).

Las articulaciones se deben examinar con meticulosidad en búsqueda de tumefacción, limitación funcional e hipersensibilidad o hiperalgesia. Los exantemas cutáneos pueden sugerir enfermedad viral o autoinmune como la ARJ. (4-12 libro-13)

Es importante tener en cuenta los signos de alarma que se pueden encontrar al examen físico como cefalea importante no habitual, exantema petequeal o inespecífico progresivo o con hiperestesia cutánea, cicatrices de varicela reciente (por probabilidad de inmunodeficiencia transitoria) o forunculosis recurrente, estado toxoinfeccioso o de impregnación, que requieren de una intervención inmediata (4).

Con los datos recabados hasta el momento, se evaluará la necesidad de estudios complementarios y eventual tratamiento. Posteriormente, se considerará la conveniencia de hospitalización dependiendo de la ansiedad de los padres, necesidad de documentar la fiebre y la indicación de pruebas diagnósticas que no se puedan hacer de forma ambulatoria (4-6-10).

Dentro de los exámenes complementarios iniciales a solicitar, se debe considerar hemograma completo con fórmula leucocitaria y frotis, cultivo de sangre y orina, sedimento urinario, medio interno, electrolitos, enzimas hepáticas, eritrosedimentación, reactantes de fase aguda como PCR y ferritina. En base a los antecedentes recolectados en la anamnesis valorar la necesidad de serologías para enfermedades que pueden asociarse con FOD como CMV, EBV, toxoplasmosis, bartonelosis, HIV y PPD.

En cuanto a los estudios por imágenes, se reservarán para casos específicos en los cuales puedan aportar datos que justifiquen sus riesgos (principalmente en el caso de tomografía computada y resonancia magnética). (6) Los estudios radiológicos de senos paranasales, abdomen y tórax pueden estar indicados en ciertos casos, pero no deben hacerse de forma rutinaria. En ocasiones es necesario realizar fondo de ojo, ecocardiograma y ecografía abdominal en búsqueda de focos profundos de infección. (13)

Por último, si el niño no muestra compromiso del estado general ni signos ni síntomas específicos de una enfermedad particular, solo es necesario la observación y evaluación periódica por parte del médico tratante hasta que aparezcan nuevos signos que puedan conducir a otros estudios y/o evaluaciones. (12 libro)

El objetivo de la evaluación del niño febril y de buena apariencia sin una fuente aparente de infección en el examen es determinar el riesgo de una infección bacteriana clínicamente oculta y la necesidad de más investigación y / o terapia con antibióticos.

Diagnóstico diferencial

En ocasiones existen múltiples episodios de infecciones benignas autolimitadas con fiebre, que los padres suelen percibir como un episodio febril prolongado, los cuales se denominan pseudo-FOD. Esta suele iniciar como una infección bien definida, seguida de otros cuadros no tan bien definidos.

Cuando la FOD se asocia a infecciones recurrentes es preciso sospechar inmunodeficiencia. En cambio si se asocia a antecedentes de atopia y el paciente presenta enfermedades autoinmunes, se debe sospechar causa reumatológica.

Es oportuno también indagar sobre consumo medicamentos, ya sea por patología de base o por el propio cuadro de FOD, ya que existen cuadros febriles de causa medicamentosa. (6)

Tratamiento, seguimiento y pronóstico

El tratamiento de la FOD en pediatría puede ser excesivo si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos está causada por enfermedades leves y autolimitadas. (6)

El tratamiento de esta entidad dependerá evidentemente de la causa y del estado clínico del paciente. No se recomienda el tratamiento empírico con antibióticos y se sugiere suspender los tratamientos farmacológicos no esenciales. (3-6)

Hay que tener en cuenta las posibles indicaciones de hospitalización, entre ellas el mal estado general, progresión de los síntomas o deterioro clínico, necesidad de observación o realización de estudios o procedimientos, riesgo social, sospecha de Munchausen. (10)

El tratamiento antibiótico empírico se reservará únicamente cuando el paciente se encuentra gravemente enfermo, no puede esperar un período de observación o existe una alta sospecha diagnóstica (previa toma de cultivos orientados a la sospecha clínica). (4-6)

Se recomienda que la fiebre sea tratada con antipiréticos solo si le genera malestar al niño. Los medicamentos antipiréticos se deberán dosificar de acuerdo al peso. Los más utilizados son Paracetamol o Ibuprofeno. La aspirina no debe utilizarse debido a la asociación con Síndrome de Reye. (2)

El pronóstico es variable y dependerá de la causa, pero en general es bueno correspondiendo a enfermedades benignas y autolimitadas, y

se suele curar sin arribar a un diagnóstico. (3-6)

En todos los pacientes con síndrome febril prolongado se deberá asegurar el seguimiento en cuanto a su evolución clínica y hasta la normalización de los exámenes de laboratorio. Es importante tener siempre presente que si bien en su gran mayoría la evolución es favorable, 1 de cada 10 pacientes puede presentar un diagnóstico final de causa reumatológica y/o neoplásica. (5)

Infeciosa: Cultivos (repetir si es necesario), estudios de LCR si corresponde, prueba de anticuerpos o molecular específica, PCR/ERS si sospecha endocarditis, osteomielitis o absceso, antibióticos empíricos (después de los cultivos) si cuenta con aspecto enfermo.

Oncológica: ácido úrico, lactato deshidrogenasa, ferritina, frotis de sangre periférica, radiografía de tórax, mantener corticoides. Continúa sin origen identificado, derivar a especialista o a un centro de atención especializada y, además, considerar repetir cultivos, otras serologías, biopsia de médula ósea, estudios por imágenes si corresponde (centellografía ósea, TEP, tránsito gastroduodenal, etc).

Autoinmunitaria/Reumatológica: anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, C3, C4, CH50, pruebas de función tiroidea, marcadores inflamatorios (PCR, ERS, ferritina).

Inmunodeficiencia: inmunoglobulinas, marcadores linfocitarios, considerar títulos de anticuerpos de vacunas aplicadas.

Referencias bibliográficas

1. Tolan R W Jr. Fever of unknown origin: a diagnostic approach to this vexing problem. *Clin Pediatr (Phila)* 2010; 49 (3):207- 213.
2. Ward MA. Fiebre en lactantes y niños: fisiopatología y manejo. Revisión de literatura actualizada hasta mayo de 2020. | Última actualización de este tema: 25 de marzo de 2020.
3. Calvo Rey C. Fiebre recurrente y prolongada. *Síndromes autoinflamatorios*. En: AEPap (ed.). *Curso de Actualización Pediatría 2018*. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 125-133.
4. Flynn LP. Fiebre en el niño mayor. *PRONAP 2015*. Módulo 3. Capítulo 2.
5. Sandoval Carmen, Pinochet Constanza, Peña Anamaria, Rabello Marcela, Prado Alejandra, Viviani Tamara. Síndrome febril prolongado: un desafío para el infectólogo pediatra. *Rev Chilena Infectología* 2014; 31 (1):87- 91.
6. Antoon J, Nicholas M. Potisek, Jacob A Lohr. Fiebre de origen desconocido. *PIR 2016*. Vol 1, Nº1 36-47.
7. Zornoza Moreno. Fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. *AEPap 2012*. *Act Pediatr Aten Prim*. 2012;5(3):144-8.
8. Escosa-García, F. Baquero-Artigao, A. Méndez-Echevarría. Fiebre de origen desconocido. Madrid. *Pediatr Integral* 2014; XVIII(1): 15-21.

9. Debra L. Palazzi, MEd, Morven S. Edwards, MD Robert Sundel, et. al. *Fiebre de origen desconocido en niños, etiología. Última actualización de este tema: 10 de junio de 2019.*
10. Debra L. Palazzi, MEd, Sheldon L. Kaplan, MD Robert Sundel, et. al. *Fiebre de origen desconocido en niños: evaluación. Última actualización de este tema: 22 de febrero de 2019. UpToDate.*
11. Coburn H Allen, Gary R. Fleisher, MD Sheldon L. Kaplan, et. al. *Fiebre sin origen en niños de 3 a 36 meses de edad: evaluación y manejo. Última actualización de este tema: 19 de mayo de 2020. Up To Date.*
12. Hoekelman Robert, Adam Henry, Nelson Nicholas, Weitzman Michael, Wilson Modena. *Atención Primaria en Pediatría. Año 2001. Vol 1; 141:1232- 1240.*
13. Nelson, Kliegman. *Tratado de pediatría. Edición 20. Vol 1. 1339-1343.*

***Dra. Florencia Bruggesser**

Médica UBA. Infectóloga

EPÍLOGO

PROF. DR. JUAN REICHENBACH

“No hay revolución asistencial, ni tampoco solución integral por el perfeccionamiento del sistema sanitario, o triunfo sobre la enfermedad por la optimización de la asistencia médica. El punto céntrico se ha trasladado del microbio a la sociedad; de la modificación patológica del mecanismo celular, al entendimiento de las fuerzas y relaciones sociales; de las alteraciones íntimas del protoplasma, núcleos, cromosomas, membranas, nucléolos, a las relaciones de producción. Este es el cambio: rechazar el fetichismo del síntoma, de la enfermedad, para comprender la causalidad estructural que lo genera (...)” Dr. Floreal Ferrara

En el año 1968 se creó la Residencia de Clínica Pediátrica en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, de la mano del Prof. Dr. Vicente Climent.

52 años después, medio centenar de unidades de residencias de pediatría y neonatología y de subespecialidades se distribuyen en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Tiene sus íconos, su identidad y su escuela de formación, que ha trascendido el territorio nacional, con miles de sus egresados alumbrando la salud pública del país y del exterior.

En el año 1999 elaboré el primer “Programa provincial de Pediatría de las Residencias de Profesionales de la Salud”, en una serie editada y publicada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cuando se comenzaron a planificar las residencias como un sistema en red.

En julio de 2001 edité, en coautoría, el libro “Autoevaluación de las Residencias de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sistematización preliminar para un diagnóstico”, publicación auspiciada y subvencionada por la OPS-OMS en la Argentina, donde iniciábamos el comienzo de la acreditación de nuestras unidades de residencias.

Tantos hijos ex residentes que habitan los ser-

vicios más complejos del país y del mundo y los valles, quebradas y selvas de nuestra geografía.

En la publicación “Selección de residentes, una construcción futura de la salud”, que edité en 2011, decía que el Sistema de Residencias de Profesionales de la Salud, en la Provincia de Buenos Aires, es el más antiguo en estructura y organización en todo el país.

Cuando analizamos la dimensión de las Residencias de Pediatría, Neonatología y de Sub Especialidades Pediátricas de la Provincia de Buenos Aires concluimos que son las más numerosas del país y de Latinoamérica. Que sus egresados, en más de 50 años de historia, han sembrado generosamente la provincia, la nación, Latinoamérica y el mundo con más de 10.000 ex residentes.

En el año 2012 publicamos “El programa de Pediatría” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que he dirigido, y que surge como un producto dinámico elaborado por una comisión permanente constituida por los actores necesarios (SAP, Universidades, Colegio de Médicos, PMI de la Provincia, OPS, referentes nacionales, Dirección de Capital Humano de Nación, Instructores de Residentes, Residentes, Jefes de Servicio, Jefes de Docencia, Directores de Hospital, Pedagogos, comunicadores sociales, etc.). En el cuerpo del mismo se postula la necesidad de la Educación Permanente en Pediatría, germen prolífico del “Portal de Educación Permanente en Pediatría” que lanzamos en 2013, con singular adhesión mundial (más de 15.000 suscriptores en el mundo entero).

Y es allí donde empezamos a gestar el libro “Pediatría en Red 1”, editado en el año 2015, que nos animó, febrilmente, a “Pediatría en Red 2” (2017), “La hora de Oro en Pediatría”, vol. 1 y 2 (2018) y “La Hora de Oro en Pediatría”, vol. 3 y 4 (2019). Siempre en red. La Red Pediátrica.

Los nodos de una red que tejen su propia identidad desde hace casi una década.

Identidad asistencial, académica, de extensión e investigación. Con la base de los residentes y

sus instructores, en las primeras líneas de trabajo, en el lugar de los hechos, en los escenarios cotidianos y de frente a los problemas complejos que abordan. Con sus propias investigaciones y experiencias. Con las redes tejidas desde las bases mismas.

En “*Pediatría en red 3*” participan más de 400 colaboradores.

El propósito es el de imaginar la salud del niño, la niña y los adolescentes desde una perspectiva de género y de derecho.

Y es por ello que en sus letras reflexionan antropólogas, psicólogas, enfermeras, economistas de la salud, nutricionistas, comunicadores sociales, poetas, pediatras, abogadas, neonatólogos, médicos de familia, funcionarios, académicos, profesores de medicina, de humanidades, de psicología, odontólogos, cirujanos, la comunidad, estudiantes de medicina, decanos de facultades, miembros del Foro de decanos de Universidades públicas, ministras de salud, funcionarios de regiones sanitarias, directores de Escuelas de Salud, sanitaristas, rehabilitadores, políticos, sanitaristas, epidemiólogos, residentes de pediatría, de neonatología, de especialidades pediátricas, presidentes de Organizaciones internacionales (Wonca CIMF), presidentes de sociedades de pediatría nacionales, extranjeras, presidentes de Sociedades de Medicina General, presidentes honorarios de fundaciones por la infancia, instructores de residentes, directores de hospitales, Jefes de Servicio, Funcionarios de Hospitales Nacionales, provinciales, municipales, internacionales, pedagogas, bibliotecarias, especialistas en oncohematología pediátrica, endocrinología pediátrica, desarrollo, nefrología pediátrica, cardiología pediátrica, cirugía pediátrica, infectología pediátrica, transportes y emergencias pediátricas, dermatología pediátrica, neumonología, terapistas pediátricos, fisiólogos, bioquímicos, especialistas en adolescencia, toxicólogos, magister, doctores en Medicina, consultores, estomatólogos, especialistas universitarios en pediatría e infectología pediátrica, concurrentes, especialistas en inmunología pediátrica, especialistas en adolescencia, especialistas en ginecología infanto juvenil, especialistas en farmacología, especialistas en ortopedia y traumatología infantil, especialistas en psiquiatría infantil, licenciados en salud ambiental, especialistas en hepatología infantil. Hospitales, regiones sanitarias, secretarías de

salud municipales, entre otros.

Pertenecen a más de 60 centros nacionales, provinciales, internacionales, municipales, hospitales especializados, generales, municipales, secretarías de salud, regiones sanitarias, CAPS, consejos vecinales de salud.

Y sociedades científicas nacionales e internacionales, fundaciones, programas nacionales, universidades nacionales e internacionales, con cátedras diversas, institutos de investigación, escuelas de salud pública.

Esta red presente y futura es el fundamento del renacimiento del Portal de Educación Permanente en Pediatría “*Profesor Dr Vicente Clement*”, como se rebautizó, en homenaje a ese pequeño gran hombre, el pionero de nuestras residencias.

Es una red sinérgica, con los actores de ayer, de hoy y de mañana, que lideran las sonrisas de la salud infantil en los más alejados ríos o en las más populosas ciudades.

Ellos son los nodos de esta red de actitudes y aptitudes, en pos de la equidad en la salud infantil.

Este emprendimiento no tiene epílogo. Tiene comienzo. Es circular, con vaivenes, dialéctico. Pero los hilos se multiplican, año tras año, con la energía de los más jóvenes y la humanidad y profesionalismo de los instructores de residentes, los líderes necesarios.

Seguramente cambiarán los actores, los territorios, los problemas.

Deberá persistir la red de afectos, de aptitudes, de actitudes.

Deberemos medir los efectos, en unidades de inclusión, equidad, acceso, salud y sonrisas.

La *Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”*, es un faro recién nacido pero eterno, imprescindible, que de la mano del Dr. Mario Rovere seguirá siendo, a pesar de los obstáculos cotidianos, la cuna de un equipo de salud que ha impactado e impactará sobre la salud de nuestros niños en disímiles geografías nacionales y del exterior.

Son estos algunos de los vectores de la direccionalidad futura.

Para ello cuenta con el peso de su historia y con el mejor de los capitales en salud: el humano.

Respira con la mística de tantos esforzados instructores y profesores del ayer, con la ener-

gía de los jóvenes que nos han visto envejecer, con las ansias y la imaginación de los pediatras y con la necesidad de nuestros niños.

No es poco capital para este siglo de mutaciones.

Habrà que implementar nuevos escenarios y nuevas formas docentes asociativas, participativas.

La esencia no cambiarà. Sólo se trata de fortalecer el concepto de la fugacidad de los conocimientos y el de la persistencia de la reflexión en nuestro objeto de estudio: la salud de los niños.

Es esta dialéctica e inasible lógica la que nos despierta cada mañana con la mágica curiosidad de lo nuevo, con la rejuvenecida fantasía del residente, del estudiante de siempre.

Y ése es el motivo de la esperanza constante.

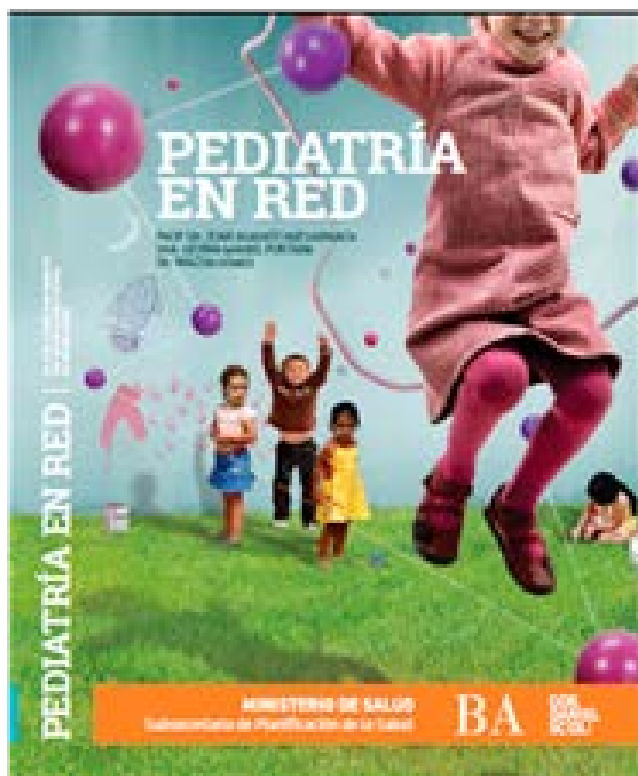
La que transfigura el hecho científico en una acción artesanal y humanitaria.

EDICIONES RED PEDIÁTRICA

- ❖ Portal de Educación permanente en Pediatría (2013). Interrumpido en 2018



- ❖ Pediatría en Red 1 (2015)



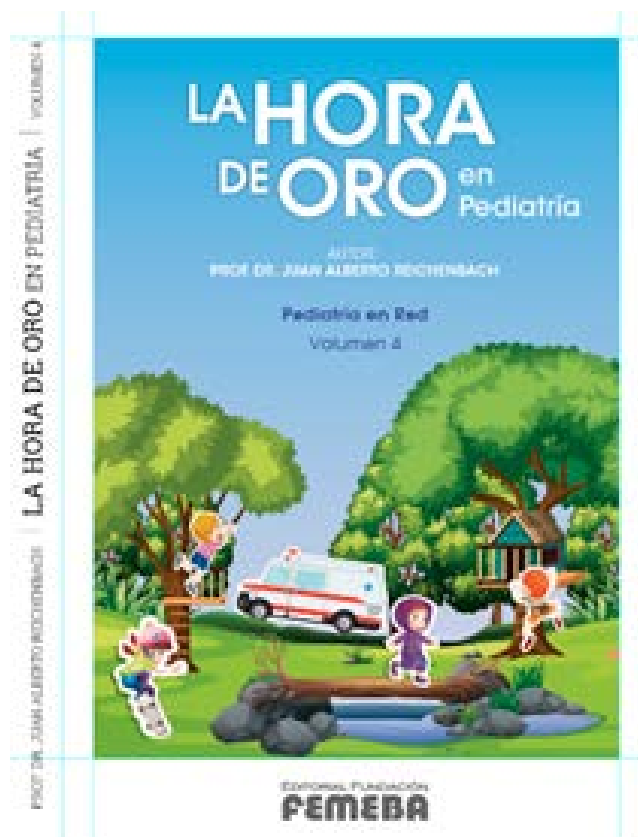
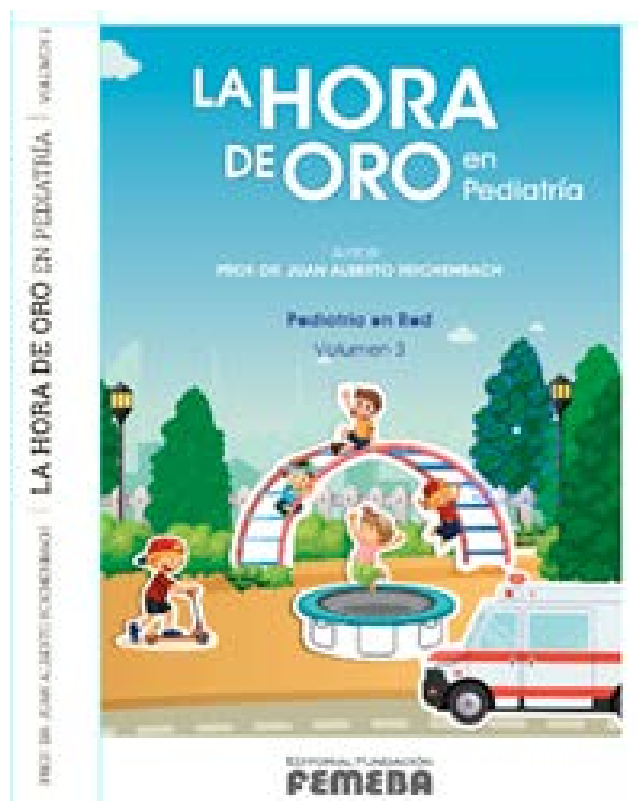
- ❖ Pediatría en Red 2 (2017)



- ❖ La Hora de Oro en Pediatría. Volumen 1 y 2 (2018)



❖ La Hora de Oro en Pediatría. Volumen 3 y 4 (2019)



Este libro se terminó de imprimir el 21 sept.2020 en Tecno Offset, Servicios gráficos editoriales. Araujo 3293 Ciudad de Buenos Aires

Pediatría en red 3 aporta una combinación única de temas médicos, psicológicos, culturales y sociales, que acompañan con un lenguaje sencillo, con reflexiones y con datos propios una práctica pediátrica adaptada a nuestras realidades.

La obra que estudiantes, profesionales y lectores interesados en general tienen hoy entre manos representa justamente eso: una verdadera cartografía de la práctica de la pediatría general hoy. El Ministerio de Salud de la Provincia y su histórica Escuela de Sanidad, hoy rebautizada y lanzada al futuro como Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” ha contado y cuenta con un profesional, con un pediatra, con un profesor que ha hecho de la producción y circulación del conocimiento una verdadera identidad, trabajando incansablemente en repositorios digitales, en textos, y en obras de distinto porte otorgando una identidad al rol de rectoría del Ministerio en las residencias pediátricas.

Dr. Mario Rovere. Director Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara

